ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

El Gran Libro

RECONSTRUCCIONES

2013–2025 exámenes EUNACOM

Preguntas reales con comentario razonado



2.739 PREGUNTAS REALES · 16 EXÁMENES

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

ÍNDICE GENERAL DE RECONSTRUCCIONES HISTÓRICAS

Distribución por Módulos y Especialidades · EUNACOM 2013 - 2025

TOTAL: 2.708 PREGUNTAS

TOMO	ESPECIALIDAD	PREGUNTAS HISTÓRICAS	VINCULACIÓN A MANUAL AEE
📂 **MÓDULO 1: MEDICINA INTERNA**			
01	Cardiología	176 preguntas reales	Tomo 01 · Manual de Cardiología
02	Infectología	110 preguntas reales	Tomo 02 · Manual de Infectología
03	Gastroenterología	181 preguntas reales	Tomo 03 · Manual de Gastroenterología
04	Respiratorio / Neumología	127 preguntas reales	Tomo 04 · Manual de Respiratorio
05	Nefrología	56 preguntas reales	Tomo 05 · Manual de Nefrología
06	Diabetes Mellitus & Nutrición	73 preguntas reales	Tomo 06 · Manual de Diabetes Mellitus & Nutrición
07	Endocrinología & Metabolismo	94 preguntas reales	Tomo 07 · Manual de Endocrinología & Metabolismo
08	Hematología & Hemostasia	84 preguntas reales	Tomo 08 · Manual de Hematología & Hemostasia
09	Reumatología	64 preguntas reales	Tomo 09 · Manual de Reumatología
10	Neurología & Geriatría	82 preguntas reales	Tomo 10 · Manual de Neurología & Geriatría
📂 **MÓDULO 2: CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES**			
11	Cirugía General & Anestesia	97 preguntas reales	Tomo 11 · Manual de Cirugía General & Anestesia
12	Traumatología & Ortopedia	93 preguntas reales	Tomo 12 · Manual de Traumatología & Ortopedia
13	Urología	84 preguntas reales	Tomo 13 · Manual de Urología
14	Otorrinolaringología (ORL)	69 preguntas reales	Tomo 14 · Manual de Otorrinolaringología (ORL)
15	Oftalmología	57 preguntas reales	Tomo 15 · Manual de Oftalmología
16	Dermatología	57 preguntas reales	Tomo 16 · Manual de Dermatología
17	Psiquiatría & Salud Mental	210 preguntas reales	Tomo 17 · Manual de Psiquiatría & Salud Mental
📂 **MÓDULO 3: MATERNO - INFANTIL**			
18	Pediatría & Neonatología	406 preguntas reales	Tomo 18 · Manual de Pediatría & Neonatología
19	Obstetricia & Materno-Fetal	167 preguntas reales	Tomo 19 · Manual de Obstetricia & Materno-Fetal
20	Ginecología & Oncología	246 preguntas reales	Tomo 20 · Manual de Ginecología & Oncología
📂 **MÓDULO 4: SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN**			
21	Salud Pública, Bioética & GES	175 preguntas reales	Tomo 21 · Manual de Salud Pública, Bioética & GES

CARDIOLOGÍA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 01

176 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

37 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.001	Angina crónica estable	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 01 · 2.1 (Pág. 18)
1.01.1.002	Bloqueos aurículo-ventriculares	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13)
1.01.1.003	Cardiopatía congénita en adulto	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	13 Q	Tomo 01 · 4.2 (Pág. 44)
1.01.1.004	Corazón pulmonar crónico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · 4.2 (Pág. 44)
1.01.1.005	Dislipidemias	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 01 · 4.3 (Pág. 46)
1.01.1.007	Endocarditis infecciosa y no infecciosa	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 01 · 3.1 (Pág. 29)
1.01.1.009	Estenosis aórtica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 01 · 2.4 (Pág. 24)
1.01.1.010	Estenosis mitral	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · C.28 (Pág. 60)
1.01.1.012	Fibrilación auricular crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9)
1.01.1.013	Fibrilación auricular paroxística	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9)
1.01.1.014	Flutter auricular	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · 1.3 (Pág. 9)
1.01.1.015	Hipertensión arterial esencial	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	19 Q	Tomo 01 · 5.1 (Pág. 53)
1.01.1.016	Hipertensión arterial secundaria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37)
1.01.1.017	Insuficiencia aórtica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37)
1.01.1.018	Insuficiencia cardíaca	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37)
1.01.1.019	Insuficiencia mitral	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · 3.5 (Pág. 37)
1.01.1.020	Miocardiopatías	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 20)
1.01.1.021	Paciente con soplo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57)
1.01.1.022	Pericarditis aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 01 · 5.3 (Pág. 57)
1.01.1.024	Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.2.001	Angina inestable	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · 2.2 (Pág. 20)
1.01.2.002	Disección aórtica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 01 · 2.3 (Pág. 22)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.2.004	Infarto agudo al miocardio	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	15 Q	Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35)
1.01.2.005	Insuficiencia cardíaca aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 01 · 3.4 (Pág. 35)
1.01.2.006	Paro cardiorespiratorio	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)
1.01.2.008	Taponamiento pericárdico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · 1.4 (Pág. 11)
1.01.2.009	Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 01 · 1.5 (Pág. 13)
1.01.3.003	Manejo del paciente en tratamiento anticoagulante	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · 2.3 (Pág. 22)
1.01.4.001	Coronariografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · 1.1 (Pág. 5)
1.01.4.002	Angiotac de tórax y aorta	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.4.005	Cintigrafía de perfusión miocárdica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.4.006	Ecocardiografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.4.007	Electrocardiograma	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.4.008	Test de esfuerzo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.4.014	Holter de ritmo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.5.004	Desfibrilación	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)
1.01.5.006	Resucitación cardiorespiratoria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 01 · Cardiología (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 128 1.01.1.013 · Fibrilación auricular paro

Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular conservada. Hemodinámicamente estable. ¿Cuál es el fármaco de elección para control de frecuencia?

A) Metoprolol oral
B) Amiodarona EV
C) Digoxina EV
D) Flecainida oral
E) Sotalol oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

FA con respuesta ventricular rápida estable y FEVI conservada: control de frecuencia con betabloqueador (metoprolol) o calcioantagonista (diltiazem/verapamilo). Metoprolol es primera línea.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 154 1.01.1.013 · Fibrilación auricular paro

Un hombre de 35 años consulta por palpitaciones intensas, que iniciaron tras 4 días de consumo abundante de alcohol. Al examen Fsico se palpa pulso irregular a 160 la8dos por minuto y se constata presión arterial de 105/67 mmHg. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Taquicardia sinusal
B) Taquicardia paroxís2ca supraventricular
C) Taquicardia ventricular
D) Fibrilación auricular
E) Taquicardia auricular mul2focal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por ser irregular, lo más probable es que sea una fibrilación auricular (FA), que, por cierto es muy frecuente. La taquicardia sinusal y la TPSV son regulares. La taquicardia ventricular puede ser regular o irregular, pero suele ser mucho más grave y tener alguna patología de base. La TAMF es irregular, pero es mucho menos frecuente. De todos modos, se debe realizar un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico. El manejo de la FA aguda es 0. Si hemodinamia inestable: cardioversión eléctrica inmediata. Si hemodinamia estable: 1. An<coagular (en la práctica se anticoagulan todos los pacientes con FA aguda o "de reciente comienzo" en la actualidad: única excepción es la autolimitada de corta duración); la necesidad de conGnuar con TACO dependerá del CHADS2, igual que en la FA crónica. 2. Bajar la frecuencia cardíaca (verapamilo, betabloqueo o dilGazem) y 3. Cardiover<r farmacológicamente (amiodarona), cuando sea seguro: 3.1. después de descartar trombos con una ecocardiografía transesofágica o 3.2. después de 3-4 semanas, 3.3. siendo discuGble si se puede hacer sin la ecocardiografía, si es que ha pasado menos de 48 horas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 92 1.01.1.013 · Fibrilación auricular paro

Un paciente de 73 años, diabético e hipertenso, en tratamiento farmacológico con enalapril, hidroclorotiazida, glibenclamida y metformina, presenta crisis de palpitaciones que duran 1 a 4 horas y que se han repetido en 5 ocasiones, durante las últimas semanas. Actualmente su examen físico muestra una frecuencia cardíaca es 62x', regular; su presión arterial, 133/83 mmHg y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tonos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, simétrico, sin otros ruidos. A continuación, se muestra un electrocardiograma tomado durante una de las crisis: Foto 7 (https://www.emedicinehealth.com/XXXXXXXXXX/article_em.htm). ¿Qué fármaco es el más importante agregar en este momento?

A) Antiagregantes
B) Adenosina
C) Verapamilo
D) Acenocumarol
E) Betabloqueantes

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una fibrilación auricular paroxística. Tiene baja frecuencia cardíaca, por lo que no se debe iniciar verapamilo ni betabloqueo. Por ser hipertenso y diabético, tien 2 puntos del CHADS2, por lo que se debe anticoagular.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 173 1.01.1.013 · Fibrilación auricular paro

Una mujer de 62 años, consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociada a disnea. Al examen físico tiene pulso irregular, a 130 latidos por minuto, con PA: 110/70 mmHg. Su examen cardíaco muestra soplo diastólico III/VI, más un pequeño soplo sistólico eyectivo. Su electrocardiograma muestra una taquicardia irregular, con complejos QRS angostos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar propanolol y antiagregantes
B) Administrar enoxiheparina y verapamilo
C) Administrar heparina y amiodraona
D) Realizar cardioversión eléctrica
E) Administrar adenosina y anticoagulantes orales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una fibrilación auricular aguda y rápida. El soplo da cuenta de que de base probablemente tiene una valvulopatía y probablemente sí valga la pena anticoagularla (aunque por tener menos de 48 horas y no tener un ecocardiograma transesofágico, no es del todo claro). Tanto B, como C son respuestas correctas, ya que incluyen la anticoagulación, más algún fármaco que maneje ritmo o frecuencia. Conversando con varios especialistas, no están de acuerdo, pero tienden a dejar la B como una mejor respuesta, ya que 1. las heparinas de bajo peso molecular suelen ser más fáciles de usar, 2. está muy taquicárdica, así que lo más urgente es controlar la frecuencia y 3. les da miedo usar la amiodarona, por si tuviera un trombo, al menos hasta que se haga la ecocardiografía transesofágica y se descarte. Por no tener compromiso hemodinámico, no está indicada la cardioversión eléctrica. La adenosina se usa en la TPSV. Los antiagregantes actualmente no están indicados en la FA.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 45 1.01.1.013 · Fibrilación auricular paro

Paciente de 35 años de edad, consulta por cuadro de 2 días de palpitaciones de dos días de evolución asociado a disnea en algunas ocasiones. Al ingreso se conecta a monitor donde se observa presencia de taquiarritmia irregular de complejo angosto. Al examen físico se encuentra consciente y orientada temporoespacialmente, bien perfundida e hidratada, examen pulmonar normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar cardioversión eléctrica
B) Indicar enoxaparina y amiodarona
C) Indicar acenocumarol y betabloqueo
D) Indicar heparina de bajo peso molecular y verapamilo
E) Indicar heparina no fraccionada y flecainida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una FA rápida, mayor a 48 horas. Se debe anticoagular y controlar la FC mientras tanto. Siempre se inicia la anticoagulación con heparina (es mejor la de bajo peso). Para controlar la FC tenemos propanolol, digital y verapamilo. Aún así, esta pregunta es muy discutible, ya que por no tener ningún criterio de CHADS2, incluso se podría no anticoagular. Sin embargo no hay que rebuscarse y hay que simplificar la pregunta a ¿cómo se maneja una FA de más de 48 horas?. También se puede criticar la pregunta porque dice 2 días y eso puede ser más o menos de 48 horas: pero en las alternativas no aparece el manejo de una FA de menos de 48 horas (cardioversión farmacológica), por lo que la pregunta debe interpretarse así. Habría que revisar cómo estaba originalmente redactada esta pregunta.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 1 1.01.1.013 · Fibrilación auricular paro

Paciente de 53 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de medianos esfuerzos asociado a palpitaciones intermitentes desde hace un mes. Al examen físico destaca ritmo irregular asociado a aumento de R1. El diagnóstico más probable es:

A) Flutter auricular
B) Taquicardia ventricular
C) Taquicardia paroxística supraentricular
D) Fibrilación auricular
E) Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fibrilación auricular** (opción **D**). Tiene una Estrenosis Mitral con FA. La presencia de pulso irregularmente irregular (arritmia completa), palpitaciones y disnea orienta de forma decisiva a fibrilación auricular. El antecedente de sobrecarga o valvulopatía (R1 reforzado por estenosis mitral o dilatación auricular izquierda por HTA) es el principal detonante anatómico y arritmogénico según el Perfil V3 EUNACOM.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 1 1.01.1.013 · Fibrilación auricular paro

Un paciente hipertenso bien controlado, con antecedente de EPOC, presenta un cuadro de palpitaciones y disnea, siendo diagnosticado de fibrilación auricular. ¿Qué fármaco está contraindicado?

A) Atenolol
B) Digoxina
C) Enalapril
D) Acenocumarol
E) Amlodipino

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El EPOC contraindica los betabloqueadores, como el atenolol. En cambio los beta-agonistas (como el salbutamol) son parte del tratamiento del EPOC. Lo mismo aplica al asma.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 98 1.01.2.002 · Disección aórtica

Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que se irradia a cuello y dorso. A lo anterior se agregó dolor intenso en la extremidad superior izquierda. Al examen físico tiene FC: 120x', PA: 200/140 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, sin soplos, murmullo pulmonar bilateral conservado, sin otros ruidos, extremidad superior izquierda con disminución del pulso radial y frialdad de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pericarditis aguda
B) Disección aórtica
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto agudo al miocardio
E) Embolias cardíacas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Disección aórtica** (opción **B**). La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 22 1.01.2.002 · Disección aórtica

Paciente masculino de 55 años con dolor torácico desgarrador de inicio súbito, irradiado a la espalda. TA en brazo derecho 185/100 y en brazo izquierdo 140/80. TC: disección de aorta tipo B de Stanford. ¿Cuál es el manejo inicial?

A) Manejo médico: control de frecuencia cardíaca y presión arterial
B) Cirugía de emergencia
C) Trombólisis sistémica
D) Endoprótesis aórtica de urgencia
E) Anticoagulación con heparina EV

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Disección aórtica tipo B de Stanford (no compromete aorta ascendente): manejo médico con betabloqueadores para reducir FC <60 lpm y PA sistólica 100-120 mmHg. Cirugía solo si hay complicaciones.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 157 1.01.2.002 · Disección aórtica

Paciente con dolor torácico EVA 10/10 retroesternal con irradiación a dorso, pulso radial izquierdo débil y llene capilar enlentecido. ¿Diagnóstico más probable?

A) SCA con elevación del ST
B) Tromboembolismo pulmonar masivo
C) Disección aórtica
D) Rotura esofágica (Boerhaave)
E) Neumotórax a tensión

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Disección aórtica** (opción **C**). Disección aórtica. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 12 1.01.2.002 · Disección aórtica

Un paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión, en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico, EVA 9/10, irradiado a dorso, asociado a malestar general y sudoración. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 170/110 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos, con presencia de un soplo cardíaco diastólico aspirativo, de intensidad IV/VI, de ubicación paraesternal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumotórax
B) Aneurisma de la aorta ascendente
C) Infarto miocárdico con rotura del músculo papilar
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Disección aórtica tipo A

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una clásica disección aórtica, con el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica (se diseca la válvula). Es tipo A, porque, al afectar la válvula, obviamente está sobre la subclavia izquierda.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 16 1.01.2.002 · Disección aórtica

Paciente de 50 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento irregular con hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico de 30 minutos de duración, transfixiante, irradiado a epigastrio, asociado a mareos y diaforesis. Al examen se aprecia pálido, sudoroso, PA 150/90, FC: 110x', saturación de oxígeno de 93% con FiO2 ambiental, ritmo regular, asociado a soplo diastólico II/ VI y disminución del segundo ruido, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos presentes. Al ingreso se solicita ECG que muestra alteraciones inespecíficas en pared anterolateral, además troponinas que están con resultado pendiente. El diagnóstico más probable es:

A) Disección aórtica
B) Infarto agudo al miocardio sin supradesnivel de ST
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infarto mesentérico
E) Pancreatitis aguda

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Disección aórtica por el soplo diastólico. La disminución del R2 y el soplo son por la insuficiencia Aórtica

---

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 144 1.01.2.002 · Disección aórtica

Un paciente de 63 años, con antecedente de hipertensión y dislipidemia, en tratamiento con losartán, hidroclorotiazida y atorvastatina consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico intenso, EVA 9/10, irradiado al dorso. Al examen físico está diaforético y angustiado, con FC: 115x', PA: 220/117 mmHg, examen pulmonar con crépitos escasos bibasales y examen cardíaco con choque de la punta no desplazado y auscultación con ritmo regular, en dos tiempos con ruidos apagados. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal y troponinas plasmáticas, que resultan negativas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumotórax
B) Infarto agudo al miocardio
C) Taponamiento pericárdico
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Disección aórtica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Orientan a disección aórtica la irradiación al dorso, la concomitancia con una crisis hipertensiva, el EKG sin signos de isquemia y las troponinas normales, que hacen menos probable un infarto. Se debe estudiar con angioTAC de tórax. Se maneja con drogas antiHTA por vía endovenosa y con cirugía, si es tipo A (sobre subclavia).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 143 1.01.2.002 · Disección aórtica

Un paciente de 65 años, hipertenso de larga data, mal controlado, consulta por dolor torácico intenso, EVA 8/10, transfixiante. Al examen físico se observa angustiado y sudoroso, con FC: 115x' PA: 160/110 mmHg, murmullo pulonar presente, simétrico y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, con auscultación de un soplo diastólico III/VI en el precordio. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal y las enzimas cardíacas resultan negativas. El diagnóstico más probable es:

A) Neumotórax
B) Espasmo esofágico
C) Infarto agudo al miocardio
D) Síndrome aórtico agudo
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una disección aórtica clásica, debido al soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. Se debe estudiar con angioTAC y, en este caso, por ser probablemente tipo A, se debe operar (ya que está afectando la válvula aórtica y, por ello, se puede asumir que disecó sobre la subclavia izquierda).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 12 1.01.2.002 · Disección aórtica

Un paciente de 75 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor torácico intenso, de inicio súbito, que alcanza un EVA 7/10, de 2 horas de evolución. El dolor tenía una localización retroesternal, pero luego migra a la zona dorsolumbar. Al examen físico destaca disminución de los pulsos de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto agudo al miocardio
B) Aneurisma de la aorta abdominal complicado
C) Tromboembolismo pulmonar masivo
D) Disección aórtica
E) Neumotórax

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Disección aórtica** (opción **D**). Es una disección clásica por la asimetría de pulsos.. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 37 1.01.2.002 · Disección aórtica

Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso, presenta dolor torácico intenso, irradiado al dorso, EVA 9/10. Al examen físico está taquicárdico, con presión arterial es de 160/110, examen cardiaco con RR2T y se ausculta un soplo diastólico en el reborde esternal derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Pericarditis aguda
C) Infarto agudo al miocárdico con rotura de la pared libre
D) Infarto agudo al miocárdico con rotura del tabique interventricular
E) Disección aórtica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Disección aórtica** (opción **E**). El soplo diastólico (rotura de la válvula aórtica) y la HTA orientan a disección.. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 180 1.01.2.002 · Disección aórtica

Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y levotiroxina, consulta por dolor torácico intenso, que inició hace 22 horas, inicialmente con EVA 9/10, que se irradiaba al dorso y posteriormente al abdomen. Tomó analgésicos y el dolor disminuyó de intensidad, sin embargo, persiste 5/10, por lo que decidió consultar. Al examen físico, tiene FC: 98x', PA: 170/112 mmHg, pulsos de extremidades superiores conservados y disminución de los pulsos de las extremidades inferiores; examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y examen pulmonar con murmullo vesicular presenta y simétrico, sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Ecocardiograma transtorácico
B) Angiografía coronaria
C) AngioTAC de tórax y abdomen
D) Radiografía de tórax
E) Troponinas plasmáticas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **AngioTAC de tórax y abdomen** (opción **C**). Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 76 1.01.2.002 · Disección aórtica

Una paciente de 30 años, con antecedente de enfermedad de Marfán, puérpera hace un mes, consulta por dolor torácico precordial, opresivo, irradiado al dorso, EVA 8/10. Al examen físico tiene. Su electrocardiograma muestra taquicardia sinusal, sin otras alteraciones. El examen de elección para iniciar el enfrentamiento de esta paciente es:

A) Coronariografía
B) Ecocardiograma transtorácico
C) Dímero D
D) AngioTAC de tórax
E) Test de esfuerzo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una disección aórtica, especialmente por el antecedente de enfermedad de Marfán. La taquicardia sinusal es algo inespecífico, que también se puede ver en el IAM (aunque con signos de isquemia) y en el TEP (es más frecuente que el patrón S1Q3T3).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 53 1.01.4.006 · Ecocardiografía

Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión arterial tratada con enalapril e hidroclorotiazida, y diabetes mellitus tratada con insulina horaria, consulta por cuadro de dos meses de disnea de medianos esfuerzos, asociado a ortopnea y edema de extremidades inferiores que aumenta en las tardes. Al examen cardiopulmonar destaca ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crepitaciones bibasales. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio diagnóstico?

A) Electrocardiograma
B) Coronariografía
C) Test de esfuerzo
D) Radiografía de torax
E) Ecocardiograma

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una insuficiencia cardiaca, secundaria a cardiopatía coronaria. Hay que pedir la Ecocardiografía, para ver la función ventricular.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 102 1.01.4.006 · Ecocardiografía

Paciente de 70 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión en tratamiento, con historia de dolor torácico que aparece al esfuerzo y cede espontáneamente, la cual se desencadena cada vez con menor esfuerzo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico muestra ritmo regular en dos tiempos sin soplos, murmullo pulmonar presente sin ruidos asociados. Se realiza ECG que muestra ritmo regular y QRS ancho compatible con bloqueo completo de rama izquierda. El examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente es:

A) Test de esfuerzo
B) Ecocardiografía de estrés
C) Enzimas cardiacas
D) AngioTAC
E) Coronariografía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ecocardiografía de estrés** (opción **B**). El BCRI inutiliza el Test de esfuerzo y se debe pedir la Eco-dobutamina.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 88 1.01.4.006 · Ecocardiografía

Un paciente de 72 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace 10 años con mal manejo, acude a control. En el examen Fsico destaca pulso pedio disminuido a derecha y en sus exámenes de laboratorio presenta hemoglobina glicosilada de 8,1%. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir su estudio?

A) Ecogra:a Doppler de extremidades inferiores
B) Ple2smogra:a de registro de volumen (PVR) de extremidades inferiores
C) Electromiogra:a
D) Radiogra:a de pie
E) TAC de pie

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El examen inicial más usado para sospecha de enfermedad arterial periférica es el índice tobillo-brazo (ITB), pero como no aparece entre las alternativas y el paciente es diabético de larga data, la pleGsmografía de registro de volumen (PVR) aparece como la mejor opción. La PVR evalúa la perfusión arterial aun cuando los vasos estén calcificados, situación frecuente en diabéticos y que falsea el ITB.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 3 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico y disnea de 2 horas de evolución. Al examen Fsico presenta taquicardia a 170 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y un examen cardiopulmonar con ritmo regular en dos tonos, sin soplos, en la auscultación cardíaca y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados, en la auscultación pulmonar. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Verapamilo endovenoso
B) Amiodarona endovenosa
C) Adrenalina endovenosa
D) Adenosina endovenosa
E) Cardioversión eléctrica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una TPSV clásica. El tratamiento de primera línea son las maniobras vagales (ej. Valsalva modificado es la más recomendada en adultos y niños que cooperan; en niños pequeño se prefiere la inmersión facial en agua fría. El masaje caroVdeo se puede usar en adultos, pero no se recomienda en niños ni en adultos mayores con riesgo de ateroma caroVdeo que se pueda soltar). De segunda línea se uGlizan fármacos, siendo de elección la adenosina en bolo EV de 6 mg. Si falla, se dan hasta dos nuevas dosis de 12 mg. Si vuelve a fallar, se usa el verapamilo (contraindicado en falla cardíaca e hipotensión). Como toda taquiarritmia, si está hemodinámicamente inestable, de primera línea se maneja con cardioversión eléctrica.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 134 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Mujer de 25 años con palpitaciones paroxísticas. ECG en sinusal muestra intervalo PR corto y onda delta. Episodio de TPSV con QRS ancho. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)
B) Fibrilación auricular
C) Taquicardia ventricular
D) Bloqueo AV completo
E) Síndrome de QT largo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
PR corto + onda delta + TPSV con QRS ancho = síndrome de WPW (preexcitación ventricular por vía accesoria). La taquicardia puede ser ortodrómica (QRS estrecho) o antidrómica (QRS ancho).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 87 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Un paciente de 22 años consulta por palpitaciones de inicio súbito, rápidas y molestas, que duraron cerca de 30 minutos y desaparecieron con maniobras vagales. Refiere que había presentado episodios previos, pero de menor duración y autolimitados. Actualmente está en buenas condiciones y al examen físico, no presenta alteraciones. Trae un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioteca.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fibrilación auricular
B) Síndrome de Wolff Parkinson White
C) Bloqueo completo de rama izquierda
D) Flutter auricular
E) Síndrome de Brugada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Bloqueo completo de rama izquierda** (opción **C**). La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 44 · 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Joven de 22 años con palpitaciones súbitas de inicio y término brusco. ECG en crisis: taquicardia regular de QRS estrecho a 180 lpm. Cede con maniobra de Valsalva. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección si reaparece?

A) Adenosina IV en bolo rápido
B) Amiodarona EV
C) Metoprolol oral
D) Digoxina IV
E) Cardioversión eléctrica sincronizada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

TPSV (taquicardia paroxística supraventricular) estable: si maniobras vagales fallan, adenosina IV 6 mg en bolo rápido es el tratamiento de elección por su efecto ultrabreve sobre el nodo AV.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 141 · 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Paciente con palpitaciones regulares y taquicardia supraventricular en el ECG. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Verapamilo 5 mg EV lento
B) Amiodarona 300 mg EV
C) Cardioversión eléctrica sincronizada
D) Metoprolol 5 mg EV
E) Adenosina 6 mg IV en bolo rápido

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Adenosina 6 mg IV en bolo rápido** (opción **E**). Adenosina 6 mg IV en bolo rápido. Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 69 · 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de inicio agudo de dos horas de evolución caracterizados por palpitaciones y dolor torácico. Al ingreso se conecta a monitor que muestra frecuencia cardiaca de 200 latidos por minutos, regular y QRS angosto. La primera medida para el manejo en este caso es:

A) Realizar presión orcular
B) Realizar cardioversión eléctrica
C) Administrar adenosina endovenosa
D) Realizar masaje carotídeo
E) Administrar verapamilo endovenoso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar masaje carotídeo** (opción **D**). Tiene una TPSV y lo primero son las maniobras vagales, luego la adenosina.. Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 59 · 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Un paciente de 28 años consulta por un cuadro de 3 horas de evolución de palpitaciones intensas, asociadas a disnea. Al examen físico, tiene FC: 160 por minuto, regular, PA: 110/70 mmHg, examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amiodarona 150 mg endovenosa
B) Lidocaína 100 mg endovenosa
C) Adenosina 6mg intravenosa
D) Diltiazem 25 mg endovenoso
E) cardioversión eléctrica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Adenosina 6mg intravenosa** (opción **C**). Las maniobras vagales son el primer paso en el manejo agudo de la TPSV De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 31 · 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Mujer con síntomas ansiosos y EKG (taquicardia regular QRS estrecho aprox 150 lpm): a. Adenosina

A) Insuficiencia cardíaca
B) Fibrilación auricular
C) Infarto agudo al miocardio
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Pericarditis aguda

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Insuficiencia cardíaca). La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 140 · 1.01.1.024 · Taquicardia paroxística su

Paciente con palpitaciones paroxísticas; luego de maniobras vagales el ECG muestra intervalo PR corto y onda delta. ¿Diagnóstico más probable?

A) Taquicardia ventricular paroxística
B) Síndrome de Wolff-Parkinson-White
C) Flutter auricular con conducción variable
D) Taquicardia supraventricular por reentrada nodal
E) Síndrome de Brugada

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome de Wolff-Parkinson-White** (opción **B**). Síndrome de Wolff-Parkinson-White. La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia regular de complejos angostos con inicio y término súbitos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 85 1.01.4.008 · Test de esfuerzo

Paciente de 57 años, hipertenso en tratamiento con losartan y tabáquico, consulta por historia de 3 semanas de evolución de episodios caracterizados por dolor torácico que aparece al caminar por más de 10 minutos, el cual tiene una duración máxima de 5 minutos y luego cede al reposo, no asociado a otros síntomas. Actualmente se encuentra asintomático y su examen físico es normal. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar su estudio?

A) Radiografía de tórax
B) Ecocardiograma
C) Coronariografía
D) Electrocardiograma
E) Test de esfuerzo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una angina de esfuerzo. Si bien hay que pedir un ECG, el TE es el examen para la angina en sí. Además el test de esfuerzo es un ECG y si está malo al inicio, no se prosigue con el examen. En la vida real, sí se pedirá probablemente el ECG, pero se debe simplificar la pregunta, a ¿cómo se estudia una angina estable?... con Test d esfuerzo. Si viniera con soplo, se sospecharía una estenosis aórtica y la respuesta sería Ecografía.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 150 1.01.1.012 · Fibrilación auricular crón

Paciente de 70 años, con antecedente de EPOC tabáquico, presenta cuadro de 3 meses de aumento de su disnea basal asociado a palpitaciones. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, ritmo cardiaco irregular con ausencia de soplos y murmullo pulmonar presente con roncus y sibilancias difusas. Se realiza electrocardiograma que muestra ausencia de onda “p”, de forma irregular y presencia de QRS angosto. ¿Cuál de los siguientes fármacos estará contraindicado para el manejo de este paciente?

A) Verapamilo
B) Lanantósido C
C) Losartán
D) Amiodarona
E) Carvedilol

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La opción correcta es la **E** (Carvedilol). En este escenario clínico, carvedilol se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 97 1.01.1.012 · Fibrilación auricular crón

Mujer de 78 años con fibrilación auricular permanente no valvular, CHA_2DS_2-VASc de 4. Sin antecedente de hemorragia. ¿Cuál es el manejo antitrombótico más adecuado?

A) Anticoagulación oral con apixabán o rivaroxabán
B) Aspirina 100 mg/día
C) No anticoagular por edad avanzada
D) Heparina de bajo peso molecular
E) Clopidogrel + aspirina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
FA no valvular con CHA_2DS_2-VASc ≥2 en mujer: anticoagulación oral indicada. ACODs (apixabán, rivaroxabán) son preferibles a warfarina en el adulto mayor por menor riesgo de hemorragia intracraneal.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 127 1.01.1.012 · Fibrilación auricular crón

Paciente de 60 años con antecedente de hipertensión sin tratamiento, consulta por cuadro de un mes de palpitaciones asociado a disnea ocasional. Al ingreso se realiza electrocardiograma que muestra:

A) Flutter auricular
B) Taquicardia sinusal
C) Fibrilación auricular
D) Taquicardia auricular multifocal
E) Taquicardia ventricular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por la HTA, como porque el ECG se ve la taquicardia irregular, a QRS angosto y ausencia de onda P

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 29 1.01.1.012 · Fibrilación auricular crón

Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión y dislipidemia, consulta por dolor en las pantorrillas de dos años de evolución, que aparece al caminar y que le obliga a detenerse, luego de caminar una cuadra. Al examen físico presenta pulso irregular y ausencia de los pulsos pedios de ambas extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

A) Disección aórtica
B) Aneurisma aórtico abdominal
C) Insuficiencia venosa
D) Embolia bilateral de EEII
E) Enfermedad arterial oclusiva

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Que tenga ritmo irregular hace pensar en fibrilación auricular y embolias (isquemia aguda), pero la clínica crónica es más sugerente de enfermedad arterial periférica.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 4 1.01.1.001 · Angina crónica estable

Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y atorvastatina, presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar 2 cuadras y alcanza un EVA de 5/10. Se solicita un test de esfuerzo que demuestra aparición de un infradesnivel del segmento ST, de 2 mm en las derivadas anteriores. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Ecocardiograma
B) TAC de tórax
C) Ecocardiografía de esfuerzo
D) Coronariografía
E) Cintigrafía de perfesión miocárdica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Coronariografía). La angina estable con test de esfuerzo alterado, se estudia con coronariografía.. Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 151 1.01.1.001 · Angina crónica estable

Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epi- gástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detener- se cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diag-

A) Angina crónica de reciente comienzo
B) Fibrilación auricular paroxística
C) Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Cardiopatía hipertensiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Angina crónica de reciente comienzo). La única opción aceptable era la angina de reciente comienzo.. Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 2 1.01.1.001 · Angina crónica estable

Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus 8po 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, consulta por dolor torácico de localización precordial y carácter opresivo. El cuadro inició hace tres semanas, presentándose el dolor en relación con la ac8vidad Fsica y desapareciendo rápidamente con el reposo. Sus signos vitales muestran presión arterial 148/92 mmHg, frecuencia cardíaca 81 la8dos por minuto y saturación arterial de oxígeno de 96%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnós8co?

A) Coronariogra:a
B) Cin2gra:a miocárdica
C) Angiorresonancia de arterias coronarias
D) Test de esfuerzo
E) Electrocardiograma de 24 horas (Holter)

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una angina crónica estable. Su diagnóstico es clínico y su estudio comienza con una prueba de esfuerzo, generalmente el ECG de esfuerzo. En los casos en que no se puede realizar (amputados o pacientes que no toleran el ejercicio) y en los casos en que el electrocardiograma es ilegible (ej. BCRI), se uGlizan otras pruebas de esfuerzo, como la ecocardiografía, con dobutamina o la cintigrafía cardiaca con talio y dipiridamol. Si alguna de estas pruebas de esfuerzo resulta alterada, se procede a la coronariografía para determinar la vía de revascularización. La regla general es que se uGlice un stent cuando hay compromiso de uno o dos vasos, y se uGlice un bypass coronario cuando hay compromiso de tres vasos o de dos vasos incluyendo la arteria descendente anterior (ADA).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 82 1.01.1.001 · Angina crónica estable

Un paciente de 68 años, fumador y dislipidémico, en tratamiento con lavastatina y aspirina, comienza hace 2 meses con angina de pecho persistente, pero estable. ¿Qué fármaco es recomendable agregar?

A) Amlodipino
B) Dinitrato de isosorbide
C) Carvedilol
D) Enalapril
E) Hidroclorotiazida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo más importante en la angina crónica es revascularizar (se pide test de esfuerzo y luego angiografía, para hacer angioplastía o bypass) y, además, dejar las estatinas y sobre todo la aspirina. Sin embargo, además, sirven los nitritos, como el isosorbide o la nitroglicerina. Los demás son antihipertensivos o fármacos para la insuficiencia cardíaca.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 180 1.01.1.001 · Angina crónica estable

Un paciente de 65 años, hipertenso y diabético, consulta por disnea y dolor de precordial, que aparece en relación al ejercicio. Es usuario de aspirina, enalapril, metformina, glibenclamida y atorvastatina. Refiere que le es imposible subir más de dos pisos en su edificio o caminar más de dos cuadras sin detenerse, debido al dolor. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a unidad de salud mental
B) Solicitar test de esfuerzo
C) Solicitar troponinas
D) Indicar programa de ejercicios supervisados, con aumento progresivo
E) Iniciar anticoagulación oral Nota: pregunta añadida a la reconstrucción.

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar test de esfuerzo** (opción **B**). Fibrosis pulmonar idiopática: la más frecuente y de peor pronóstico; sin tratamiento específico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 118 1.01.1.001 · Angina crónica estable

Paciente de 58 años, con antecedente de diabetes mellitus, hipertensión y fumador de 40 paquetes año, consulta por un cuadro de tres semanas de evolución de dolor epigástrico opresivo, asociado a disnea y palpitaciones regulares, que lo obligan a detenerse cada 100 metros de caminata y ceden con el reposo. En el examen físico, su presión arterial es 140/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto regular. El diagnóstico más probable es:

A) Angina crónica de reciente comienzo
B) Fibrilación auricular paroxística
C) Isquemia cardiaca con arritmia supraventricular
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Insuficiencia cardíaca postinfarto

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una angina crónica de pared inferior (dolor epigástrico), dada la clara relación con el ejercicio. La angina mesentérica tiene dolor postingesta de comida.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 172 · 1.01.1.001 · Angina crónica estable

Paciente de 43 años de edad, con antecedente de migraña en tratamiento con propanolol, consulta por historia de dolor toráxico opresivo de 20 minutos, irradiado a miembro superior izquierdo, el cual cede esponáneamente, refiere que ha presentado dicho cuadro en dos ocasiones en su hogar luego de regresar del trabajo. Actualmente está asintomático y su exámen físico es normal. Se solicita electrocardiograma que no muestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Infarto agudo al miocárdio
B) Pericarditis aguda
C) Angina vasomotora
D) Espasmo esofágico
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una angina vasoespástica de Prinz Metal. Recordar que se diagnostica con pruebas de estimulación con acetilcolina u otros fármacos y se trata con nitroglicerina oral SOS y eventualmente un stent. Recordar además que la causa suele ser ateromatosa igual, ya que ateroma altera la respuesta vasomotora de la arteria coronaria.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 41 · 1.01.1.020 · Miocardiopatías

Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que inició hace 3 meses y que ha aumentado lentamente. Su hermano murió súbitamente a los 25 años. Al examen físico se constata un soplo sistólico eyectivo, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Síndrome de Brugada
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Síncome disautonómico
E) Síndrome de QT largo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una miocardiopatía hipertrófica clásica (síncope, antecedentes de muerte súbita en la familia, soplo eyectivo y clínica de insuficiencia cardiaca). Veremos en detalle toda la semiología cardíaca.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 54 · 1.01.1.020 · Miocardiopatías

Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70 mmHg y su pulso es de 80x', además presenta edema en las EEII. Presenta desplazamiento del choque de la punta, a dos centímetros de la línea medio-clavicular y se ausculta galope cardiaco, con un soplo sistólico en el ápex, que no varía con la inspiración. Al examen pulmonar tiene crepitos basales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Miocardiopatía dilatada
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Miocardiopatía dilatada clásica. El soplo que tiene es por insuficiencia mitral, por dilatación del anillo valvular. No aparece insuficiencia mitral en las alternativas (e igual es más probable que sea un MCP dilatada)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 179 · 1.01.1.020 · Miocardiopatías

Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia soplo sistólico que aumenta con maniobras de vansalva, sin otros hallazgos. Se estudia con electrocardiograma que muestra onda Q presente en DII, DIII y AVF, además S profunda de V1 a V3. El diagnóstico más probable es:

A) Miocardiopatía dilatada
B) Lipotimia
C) Soplo fisiológico
D) Miocardiopatía hipertrófica
E) Estenosis mitral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Debe decir S profunda. Clínica sí es de MCPHT. Viene con signos de HTVI: S profunda en V1 y V2, R alta en V5, V6. Además tiene ondas T gigantes e invertidas en las precordiales.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 3 · 1.01.1.020 · Miocardiopatías

Una paciente de 35 años, primípara, está en su cuarto día postparto vaginal. Su embarazo fue adecuadamente controlado, siendo normal durante toda la gestación. Consulta por un cuadro de disnea que ha aumentado significativamente en los últimos días, siendo actualmente de reposo. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto y presión arterial de 110/60 mmHg, con auscultación cardíaca que muestra un ritmo de galope por presencia de R3 y examen pulmonar que demuestra la presencia de crépitos basales bilaterales. Satura 94% a FiO2 ambiental y se observa edema de extremidades inferiores fóvea ++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Edema pulmonar no cardiogénico
B) Miocardiopatía periparto
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Embolia de líquido amniótico
E) Neumonía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Miocardiopatía periparto: El cuadro clínico sugiere insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción sistólica (tercer ruido). La desaturación y las crepitaciones pulmonares sugieren un edema pulmonar cardiogénico. El contexto de la paciente puérpera obliga a pensar en una miocardiopatía periparto. Si no hubiese estado embarazada, sería miocardiopatía dilatada. El tromboembolismo pulmonar presentaría un inicio súbito.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 28 · 1.01.1.020 · Miocardiopatías

Una paciente de 14 años presenta caída al suelo, con inconsciencia de 30 segundos, recuperándose luego por completo. ¿Cuál de los siguientes antecedentes orientan a una causa cardiogénica del cuadro?

A) Ausencia de episodios anteriores
B) Relación con la micción
C) Relación con el ejercicio
D) Relación con la tos
E) Ocurrencia al incorporarse desde la posición acostada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La B y la D se asocian a síncopes disautonómicos, de tipo "situacional". La E se relaciona con los síncopes ortostáticos. Tanto el ejercicio, como la ocurrencia en reposo, sin un desencadenante ni síntomas previos, sugiere etiología cardiogénica.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 1 1.01.1.019 · Insuficiencia mitral

Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumá8ca en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de esfuerzos en capacidad funcional II, que actualmente ha progresado a disnea de mínimos esfuerzos. Al examen Fsico, su presión arterial es de 120/78 mmHg, su frecuencia cardíaca es de 92 la8dos por minuto y su saturación de oxígeno es de 93% a aire ambiental. Se ausculta un soplo holosistólico en el ápex, irradiado a la axila y se palpa el choque de la punta hiperdinámico a la altura del quinto espacio intercostal. El examen pulmonar muestra crepitaciones basales bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Insuficiencia mitral
B) Insuficiencia aór2ca
C) Estenosis mitral
D) Estenosis aór2ca
E) Ductus arterioso persistente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una insuficiencia mitral clásica, con clínica de insuficiencia cardiaca izquierda (disnea y crépitos), soplo holosistólico y desplazamiento del choque de la punta, que sugiere cardiomegalia. Revisar resumen de semiología cardiaca.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 38 1.01.1.019 · Insuficiencia mitral

Un paciente de 70 años, hipertenso, presenta dolor torácico de dos días de evolución, intenso, asociado a malestar general. En las últimas horas se agrega disnea y síncopes ortostáticos. Al examen físico aparece un soplo holosistólico en el ápex. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Taponamiento cardiaco por rotura de la pared libre
B) Disección aórtica
C) Insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar
D) Endocarditis bacteriana
E) Cardiopatía hipertensiva, descompensada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Cuadro clásico (tiene soplo ed insuficiencia mitral y la historia de dolor de 2 días: tuvo un IAM hace dos días y ahora se rompió el músculo papilar).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 124 1.01.1.019 · Insuficiencia mitral

Una paciente presenta un cuadro de 2 días de disnea de esfuerzo, que aparece ante medianos esfuerzos, asociado a tos con expectoración, que en ocasiones es rosada. Al examen físico tiene FC: 94x', PA: 110/70 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales y examen cardíaco con presencia de un soplo sistólico IV/VI. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Insuficiencia tricuspídea
C) Neumopatía aguda
D) Insuficiencia mitral aguda
E) Disección aórtica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El soplo sistólico y los síntomas de ICC izquierda hacen sospechar la insuficiencia mitral. La expectoración rosada suele ser más de estenosis mitral, pero sí se puede ver en la insuficiencia mitra. Ver resumen de semiología cardíaca.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 53 1.01.1.005 · Dislipidemias

Un paciente hipertenso y diabético se realiza un perfil lipídico, que muestra triglicéridos de 350 mg/dl, colesterol LDL de 230 mg/dl y colesterol HDL de 37. ¿Qué tratamiento debe indicarse?

A) Atorvastatina
B) Gemfibrozilo
C) Insulina
D) Lovastatina más gemfibrozilo
E) Ezetimibe

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El LDL es la prioridad (a menos que los triglicéridos estén mayores a 500). Las estatinas están indicadas de inmediato cuando el LDL es mayor a 190 en pacientes de bajo riesgo CV o cuando es mayor a 100 en los diabéticos. Además cuando continúa alto el LDL, a pesar de 3 meses con dieta. Los médicos generales no deben indicar estatinas y gemfibrozilo juntos.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 157 1.01.1.005 · Dislipidemias

Un paciente de 66 años, diabético e hipertenso, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 1 año, se realiza perfil lipídico, que muestra triglicéridos: 325 mg/dl, colesterol LDL: 125 mg/dl, colesterol HDL: 30, colesterol total: 220 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo de su dislipidemia?

A) Atorvastatina 40 mg/día
B) Fenofibrato 160 mg/día
C) Gemfibrozilo 600 mg cada 12 horas
D) Aporte de ácidos grasos omega 3
E) Rosuvastatina 10 mg/día

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Atorvastatina 40 mg/día** (opción **A**). El LDL es el principal objetivo terapéutico en dislipidemias De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 139 1.01.1.005 · Dislipidemias

Un paciente de 68 años con diagnóstico reciente de ateromatosis aórtica y carotídea se realiza un perfil lipídico que muestra: colesterol total: 194 mg/dL, colesterol LDL: 93 mg/dL, HDL: 37 mg/dL y triglicéridos: 287 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Iniciar metformina
B) Iniciar gemfibrozilo
C) Iniciar atorvastatina
D) Iniciar ácido nicotínico
E) Iniciar ezetimibe

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de Dislipidemia: El paciente presenta ateromatosis aórtica y carotídea, lo que implica un riesgo cardiovascular alto, cuyo objetivo de colesterol LDL es menor a 70. Por tanto, tiene dislipidemia mixta con colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo y triglicéridos elevados. La prioridad es el colesterol LDL, por lo que el tratamiento de elección es una estatina, como la atorvastatina. Si los triglicéridos hubiesen estado sobre 500 mg/dl, sería la prioridad y la respuesta sería un fibrato.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 108 1.01.1.005 · Dislipidemias

Un paciente diabético, hipertenso y con antecedente de una cardiopatía coronaria, en tratamiento con aspirina, metformina, glibenclamida y enalapril, se realiza un perfil lipídico, que se informa como LDL: 165 mg/dl, HDL: 38 mg/dl, triglicéridos: 288 mg/dl. Inició atorvastatina 40 mg al día, las que suspendió por presentar artralgias y mialgias. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar rosuvastatina 10 mg y controlar con CK
B) Iniciar fenofibrato mg y controlar con perfil lipídico y glicemia
C) Iniciar atorvastatina 5 mg cada 2 días
D) Iniciar ezetimibe
E) Reforzar la dieta

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El LDL debe ser menor a 70, por ser de alto riesgo coronario. Por ello, se prefieren las estatinas. Eso sí, por haber tenido mialgias, se debe iniciar con una dosis más baja y controlar con CK, para asegurarse que no haya miopatía por estatinas.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 169 1.01.1.005 · Dislipidemias

Un paciente de 67 años diabético, dislipidémico e hipertenso, consulta por dolor en ambas pantorrillas, que aparece al caminar dos cuadras, impidiéndole seguir caminando. Además, refiere dolor urente de extremidades inferiores y, al examen físico, tiene disminución de la sensibilidad táctil y termalgésica de los pies, con disminución de los reflejos rotulianos y abolición de los reflejos. ¿Cuál es el examen más adecuada para confirmar el diagnóstico?

A) Ecografía Doppler de extremidades inferiores
B) Electromiografía de extremidades inferiores
C) Niveles plasmáticos de B12
D) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
E) Resonancia magnética nuclear de cerebro y médula

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Ecografía Doppler de extremidades inferiores** (opción **A**). Las dislipidemias son un factor de riesgo cardiovascular mayor y su tratamiento es esencial en la prevención de eventos ateroescleróticos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 126 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación completa. Al examen físico tiene FC: 75x', PA: 110/70 mmHg se palpa el choque de la punta en el 4° espacio intercostal, línea medio clavicular y se ausculta el corazón con presencia de soplo protomesosistólico III/VI y segundo ruido muy apagado. El examen pulmonar no muestra alteraciones. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un ritmo sinusal con onda S de 23 mm en V2 y onda R de 16 mm en V5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis mitral
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral
E) Cardiopatía coronaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una estenosis aórtica clásica. De verdad hay que leer y aprenderse el resumen de semiología cardíaca.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 174 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Una paciente de 41 años presenta disnea de grandes esfuerzos de larga data, a lo que en el úl8mo 8empo se ha agregado opresión precordial en relación a la ac8vidad Fsica, que cede con el reposo. Tiene antecedente de un soplo en la infancia no estudiado. En el examen Fsico presenta frecuencia cardíaca: 68 por minuto, presión arterial: 120/85 mmHg, pulso regular de ascenso lento y baja amplitud en ambas extremidades superiores, y se ausculta un ritmo cardíaco regular en dos 8empos con presencia de un soplo sistólico en foco aór8co III/VI y un soplo diastólico en el mismo foco II/VI. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aór2ca
C) Insuficiencia mitral
D) Insuficiencia aór2ca
E) Comunicación interauricular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una estenosis aórtica clásica (revisar resumen de semiología cardíaca), caracterizada por soplo sistólico eyectivo (foco aórtico), pulso parvus et tardus, síncopes, angina de pecho y arritmias. Aunque la presión está normal en este caso, lo clásico es que la presión de pulso (distólica - diastólica) esté disminuida, haciendo que el pulso se palpe débil (parvus = pequeño). El soplo diastólico concomitante, probablemente se deba a que Gene algún grado de insuficiencia aórtica asociada, primando el componente de estenosis. La asociación de estenosis e insuficiencia valvular se conoce como "enfermedad valvular".

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 168 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Un paciente de 80 años, hipertenso en tratamiento hace 10 años, consulta por disnea de esfuerzos, que inició hace 6 meses. Al examen físico destaca PA 150/90, ritmo regular, con ausencia del segundo ruido, asociado a soplo mesosistólico III/VI en margen esternal izquierdo, pulso carotídeo de ascenso lento y choque punta en el quinto espacio intercostal izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral
E) Miocardiopatía dilatada

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una estenosis aórtica de libro. En el manual de semiología cardíaca veremos las clínicas de todas las patologías cardíacas, ya que siempre se preguntan.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 56 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Un paciente de 79 años presenta dolor torácico opresivo, que aparece al caminar y que cede con el reposo. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico IV de VI, irradiado a la zona baja del cuello. El examen más adecuado para proseguir con su estudio es:

A) Prueba de esfuerzo
B) Electrocardiograma
C) Coronariografía
D) AngioTAC de torax
E) Ecocardiografía doppler

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta difícil. Parece una angina estable, pero en realidad es una estenosis aórtica (por el soplo) y por tanto se debe pedir ecocardio primero

---

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 101 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Un paciente de 20 años, con antecedente de soplo en su infancia, consulta por sensación de opresión precordial, que aparece al caminar, se asocia a disnea leve y que cede rápidamente con el reposo. Al examen físico tiene PA: 150/80 mmHg, FC: 63x', pulso débil, regular, de ascenso lento. El examen cardíaco muestra un soplo sistólico eyectivo, paraesternal, que se irradia al cuello. Su electrocardiograma muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Miocardiopatía hipertrófica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una estenosis aórtica clásica, probablemente congénita. Deben revisar el resumen de semiología cardíaca completo y aprendérselo hoy de una vez por todas. Insisto: hoy. El pulso débil y de ascenso lento (parvus et tardus) hace que sea una estenosis aórtica y no una MCPHT, que tiene pulso amplio o Celler.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 110 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Adulto mayor de 81 años, consulta por pérdida de conciencia súbita con recupera- ción ad integrum. Al examen físico, presión arterial de 140/90 mmHg, con frecuencia cardiaca de 75 latidos por minuto, soplo sistólico eyectivo irradiado al cuello y choque de la punta se palpa en el quinto espacio intercostal. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Miocardiopatía dilatada
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Enfermedad coronaria con afectación del sistema excito-conductor
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Estenosis aórtica** (opción **A**). Tiene el soplo clásico, más los síncopes de la estenosis aórtica. Además la edad orienta mucho.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 55 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Un paciente de 82 años ha presentado disnea de esfuerzos y ha presentado síncope, relacionado con actividad física, con recuperación total. Al examen físico presenta presión arterial 120/70 mmHg, FC: 70 x', y a la auscultación cardiaca tiene un soplo paraesternal, de tonalidad ruda, luego del primer ruido, asociada a una disminución marcada del segundo ruido. Además, el choque de la punta se palpa desplazado. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia mitral
E) Cardiopatía coronaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es estenosis aórtica por el síncope y el soplo. Eso sí, la cardiomegalia (desplazamiento del choque de la punta) aparece en estadíos muy avanzados.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 131 1.01.1.009 · Estenosis aórtica

Valvulopatía en paciente joven con síncope a. Estenosis aórtica

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 3 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de esfuerzos y ortopnea, que ha deteriorado significativamente su capacidad funcional. En el examen físico tiene pulso palpable con frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial de 155/75 mmHg y frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturando 92% a FiO2 ambiental. Al examen cardiopulmonar, tiene ritmo regular en dos tonos, con soplo sistólico eyectivo II/VI en la zona paraesternal, más un soplo diastólico, que se escucha hasta la final de la diástole en el mismo foco. Su padre falleció a los 50 años, de manera súbita. ¿Cuál es el diagnóstico más importante?

A) Recoartación aórtica
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia tricuspídea
E) Disección aórtica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Recoartación aórtica** (opción **A**). El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 147 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente asintomática, tolera el ejercicio normal. Auscultación: soplo sistólico II/VI en foco pulmonar con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tetralogía de Fallot
B) Ductus arterioso persistente
C) Estenosis pulmonar
D) Comunicación interauricular (CIA)
E) Comunicación interventricular

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
CIA: soplo sistólico de eyección en foco pulmonar (por hiperflujo pulmonar) + desdoblamiento FIJO del S2 (por sobrecarga de volumen en VD independiente de la respiración) = signo casi patognomónico de CIA. Suele diagnosticarse en embarazo por el aumento del gasto cardíaco.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 28 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Un hombre de 40 años consulta por disnea de esfuerzos de algunos años de evolución, que aparece con medianos esfuerzos, asociada a palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores, FC: 75x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos bibasales y al examen cardíaco presenta un soplo sistólico de ubicación paraesternal, con segundo ruido desdoblado fijo. Se solicita un electrocardiograma, que muestra eje a +120°, fibrilación auricular, con un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis mitral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Comunicación interauricular** (opción **A**). Es una CIA clásica, por la dilatación derecha y el desdoblamiento fijo del 2º ruido.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 32 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Pregunta 32 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 40 años, consulta por un cuadro, de algunos meses de evolución, de disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a ortopnea y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se auscultan crepitaciones pulmonares bilaterales, con un soplo en la zona paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. Su radiografía muestra signos de hiperflujo pulmonar, con botón pulmonar prominente. Su electrocardiograma muestra un patrón rSr. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interauricular
B) Dustus arterioso persistente
C) Estenosis aórtica
D) Comunicación interventricular
E) Insuficiencia aórtica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Comunicación interauricular** (opción **A**). Era una clásica CIA del adulto, con toda su clínica, excepto el desdoblamiento fijo del R2.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 86 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Un hombre de 40 años consulta por disnea y palpitaciones ocasionales. Al examen físico presenta un soplo sistólico basal, con desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Ductus arteriosos persistente
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis aórtica
E) Estenosis pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una CIA (comunicación interauricular) clásica, aunque en un adulto: soplo sistólico eyectivo, desdoblamiento del segundo ruido y eje desviado a derecha.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 57 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Un paciente de 30 años presneta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos. Presenta un soplo sistólico eyectivo, con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interventricular
B) Comunicación interauricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Tetralogía de Fallot
E) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Comunicación interauricular** (opción **B**). Cuadro clásico. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 113 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Un paciente de 18 años, asintomático, acude a control médico, para evaluación para realizar deporte. Se encuentra asintomática y en su examen físico se pesquisa la presencia de un soplo sistólico de intensidad III/VI en la zona paraesternal izquierda. Su electrocardiograma es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Estenosis aórtica
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis pulmonar
E) Ductus arterioso persistente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por clínica, parece un soplo funcional. Sin embargo, no está entre las opciones. Por estar en el foco pulmonar (paraesternal izquierdo), se debe marcar CIA. La estenosis aórtica sopla paraesternal derecho (foco aórtico). La CIV tiene soplo holosistólico y el ductus tiene soplo continuo. La estenosis pulmonar tendría otros síntomas y es mucho menos frecuente que la CIA.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 137 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Un paciente de 24 años presenta disnea de esfuerzos, asociado a edema de extremidades inferiores. Refiere antecedente de soplo en la infancia. Al examen físico tiene PA: 120/80 mmHg, FC: 74x', examen cardiopulmona con un segundo ruido desdoblado y fijo, un soplo sistólico eyectivo, paraesternal izquierdo y crepitaciones escasas en ambas bases pulmonares. El electrocardiograma muestra una imagen de bloqueo completo de rama derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interauricular
B) Comunicación interventricular
C) Coartación aórtica
D) Ductus arterioso persistente
E) Tetralogía de Fallot

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Comunicación interauricular** (opción **A**). Es una CIA clásica. Insisto, de verdad hay que aprenderse el resumen de semiología cardíaca.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 24 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Una paciente de 27 años, con antecedente de soplo en la infancia, consulta por aste- nia y disnea que aparece con medianos esfuerzos. Al examen físico presenta edema de extremidades inferiores, ritmo regular en dos tiempos con soplo sistólico intenso aso- ciado a segundo ruido desdoblado permanente, murmullo pulmonar disminuido en ba- ses con crépitos bilaterales. Su electrocardiograma muestra arritmia completa por fibri- lación auricular y bloqueo completa de la rama de His.

A) Comunicación interventricular
B) Comunicación interauricular
C) Estenosis mitral
D) Estenosis aórtica
E) Conducto arterioso persistente

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Comunicación interauricular). Es una CIA clásica.. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 148 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Adulto con disnea de esfuerzos, crepitaciones pulmonares, soplo sistólico con desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Estenosis pulmonar moderada
C) Comunicación interventricular pequeña
D) Insuficiencia tricuspídea
E) Bloqueo de rama derecha sin cardiopatía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Comunicación interauricular** (opción **A**). Comunicación interauricular. El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 68 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Sd de down q se cansaba al mamar con soplo continuo con pulso saltón:

A) DAP
B) Canal AV - cuál era esta??? DAP porque el soplo era continuo, sin embargo, canal AV es la primera valvulopatía en sd down y se preguntó en pruebas anteriores :(
C) Comunicación Inter ventricular
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (DAP). El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 17 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Una paciente de 30 años, con antecedente de soplo en la infancia, consulta por un cuadro de disnea de esfuerzos, que ha aumentado en las últimas semanas. Al examen físico, se palpa latido del corazón en la zona para esternal derecha y, en la auscultación, presenta un soplo sistólico eyectivo, asociado a desdoblamiento fijo del segundo ruido. Examen pulmonar demuestra murmullo pulmonar presente, bilateral, asociado a crepitaciones en ambas bases pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipertensión pulmonar primaria
B) Comunicación interauricular
C) Comunicación interventricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Coartación aórtica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Coartación aórtica** (opción **E**). El manejo crónico del asma tiene como objetivos principales eliminar los síntomas, prevenir hospitalizaciones y descompensaciones, prevenir complicaciones (especialmente sobreinfección bacteriana) y mantener la función pulmonar a largo plazo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 1 1.01.1.003 · Cardiopatía congénita en a

Una adolescente de 17 años se somete a una evaluación para realizar actividades de alto rendimiento deportivo. Se encuentra asintomática y en su examen físico se pesquisa la presencia de un soplo sistólico de intensidad III/VI en la zona paraesternal izquierda. Su electrocardiograma es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Hipertensión pulmonar primaria
C) Comunicación interventricular
D) Estenosis mitral
E) Ductus arterioso persistente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Clínicamente parece un soplo funcional, pero aparecía en las alternativas. De las opciones, por la ubicación del soplo, la CIA es la respuesta más aceptable.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 115 1.01.1.004 · Corazón pulmonar crónico

Un paciente de 76 años, fumador de 80 paquetes-año, con EPOC severo en tratamiento con budesonida y salmeterol inhalados, presenta aumento de su disnea e intolerancia al ejercicio desde hace 7 días, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 100 por minuto, presión arterial 110/70 mmHg e ingurgitación yugular a 45°. Se ausculta ritmo regular en dos tonos con ruidos apagados y murmullo pulmonar disminuido de manera bilateral, con roncus y sibilancias difusos. Se solicita ecocardiograma que muestra cavidades izquierdas con leve dilatación del ventrículo izquierdo y fracción de eyección conservada de 58%, y cavidades derechas dilatadas con paredes hipertróficas, con es8mación de presión de arteria pulmonar de 68 mmHg. Su radiograFa de tórax se muestra a con8nuación: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hipertensión pulmonar primaria
B) Insuficiencia cardíaca conges2va
C) Exacerbación de enfermedad pulmonar obstruc2va crónica
D) Cor pulmonale descompensado
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene síntomas de insuficiencia cardíaca derecha: astenia, edema, yugulares ingurgitadas. En el ecocardiograma se confirma la hipertrofia derecha y la hipertensión pulmonar (PAP > 25 mmHg), que no es primaria, sino secundaria al EPOC. Por tanto, es un cor pulmonar clásico. No Gene una insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), que se refiere a la ICC izquierda, con tendencia al edema pulmonar. La radiografía muestra campos pulmonares grandes, con corazón en gota, clásico del EPOC avanzado. Fuente imagen: hxps://li~l.com/.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 58 1.01.1.004 · Corazón pulmonar crónico

Un paciente de 62 años, fumador de 30 paquetes años, presenta edema de extremidades inferiores, asociado a astenia, disnea y adinamia. Al examen físico presenta yugulares visibles a 45 grados y aumento de la intensidad del segundo ruido cardiaco. Su electrocardiograma muestra una onda R prominente en V1 más un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis tricuspidea
B) Pericarditis constrictiva
C) Cardiopatía coronaria
D) Cor pulmonale
E) Cardiopatía hipertensiva

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cor pulmonale** (opción **D**). Cuadro clásico (insuficiencia cardiaca derecha, por HTP, por enfermedad pulmonar (EPOC).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 66 1.01.1.004 · Corazón pulmonar crónico

Paciente con clínica telangiectasia, esclerodermia, sindrome de raynaud e hipertensión pulmonar, examen de elección para confirmar etiologia diagnóstico: a. Ecocardiograma TE (porque no puede ser esta?) (Era un CREST y estaba asi por hipertensión Pulmonar, se dg oficialmente con Cateterismo- además ya te describían el ecocardiograma en la pregunta) b. Cateterismo cardiaco derecho c. Cintigrama pulmonar, esta hace el dx de Fibrosis pulmonar. d. Radiografía tórax

E) AgioTC de tórax
B) Hemograma y VHS
C) Ecografía
D) Radiografía
E) TAC con contraste

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **** (opción **A**). La esclerodermia (esclerosis sistémica) se clasifica en dos formas: limitada (CREST) y difusa. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 94 1.01.1.022 · Pericarditis aguda

Un paciente de 40 años, con antecedente de reflujo gastroesofágico, consulta por dolor torácico de algunas horas de evolución, tipo puntada, muy intenso. Refiere que el dolor no respondió al uso de omeprazol. En su examen físico se aprecia adolorido, con FC: 76x', PA: 110/70 mmHg, ritmo regular en 2 tonos, sin soplos. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: Foto 8 (https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=86115). El diagnóstico más probable es:

A) Pericarditis aguda
B) Espasmo esofágico
C) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared lateral
D) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferior
E) Infarto miocárdico con supradesnivel del segmento ST de la pared inferolateral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pericarditis clásica, tanto por la clínica, como por el EKG con SDST en J en casi todas las derivaciones.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 81 1.01.1.022 · Pericarditis aguda

Un hombre de 31 años, deportista, consulta por dolor precordial de 2 días de evolución, EVA 8/10, asociado a leve sensación de ahogo, que aparece especialmente al recostarse. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Infarto agudo al miocardio
B) Pericarditis aguda
C) Neumotórax espontáneo
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Costocondritis del deportista

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pericarditis clásica, tanto por la edad y la clínica (aumenta al acostarse) como por el EKG con SDST en J casi todas las derivaciones. También tiene depresión del PR en algunas.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 59 1.01.1.022 · Pericarditis aguda

Un paciente de 30 años, deportista, pregunta por dolor precordial opresivo, de dos días de evolución, irradiado al cuello y al hombro izquierdo, intenso. Además presenta disnea que aumenta al recostarse. Al examen físico está adolorido, con RR2T sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumotórax
C) Pericarditis aguda
D) Miocardiopatía hipertrófica
E) Costocondritis del deportista

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Cuadro difícil. Tiene depresión del PR. En este ECG se ven los SDST, pero en el Eunacom real solo se veía SDST en V2 y V4. Sí estaba la depresión del PR

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 139 1.01.1.022 · Pericarditis aguda

Paciente con dolor torácico retroesternal, antecedente de RGE, en buenas condiciones. ECG con elevación difusa del ST en silla de montar. ¿Diagnóstico más probable?

A) SCA con elevación del ST (SCACEST)
B) Angina inestable
C) Miocarditis aguda viral
D) Pericarditis aguda
E) Espasmo coronario (angina de Prinzmetal)

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Pericarditis aguda** (opción **D**). Pericarditis aguda. Las enfermedades del pericardio incluyen pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 29 1.01.1.022 · Pericarditis aguda

Un paciente de 40 años consulta por dolor retroesternal opresivo, irradiado al dorso, que inició después de comer y que tiene una intensidad de 8/10, con tope inspiratorio. Al examen físico tiene FC: 100x, PA: 130/88 mmHg, T°: 37,7°C, examen pulmonar normal, auscultación cardíaca con ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: www.cardioscience.com.mx): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Pericarditis aguda
C) Disección aórtica
D) Infarto agudo al miocardio de pared inferior
E) Infarto agudo al miocardio de pared anterolateral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Pericarditis aguda** (opción **B**). Las enfermedades del pericardio incluyen pericarditis aguda, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 46 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor toráxico opresivo irradiado a ambos hombros intenso EVA 9/10, asociado a disnea y sudoración. Al examen físico, su presión arterial es 140/70 mmHg con frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Presenta RR3T con presencia de R3, murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales. Electrocardiagrama: SDST en V1-V4. La conducta más adecuada es:

A) Tratamiento anticoagulante
B) Tratamiento antiplaquetario
C) Solicitar AngioTAC de tórax
D) Ecocardiograma bidimensional
E) Coronariografía de urgencia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un SCA con SDST, por lo que requiere angioplastía de urgencia (o trombolisis, que no aparecía en las opciones).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 52 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Hombre de 58 años llega a urgencias con dolor precordial opresivo intenso de 2 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, sudoración profusa y disnea. ECG: supradesnivel del ST en V1-V4. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Insuficiencia cardíaca aguda
B) Fibrilación auricular
C) Infarto agudo al miocardio con SDST
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Pericarditis aguda

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

IAM con SDST: dolor precordial opresivo + irradiación + sudoración + ECG con supradesnivel del ST = IAM con SDST (STEMI). Manejo urgente: aspirina + clopidogrel + anticoagulación + reperfusión (angioplastia primaria o trombolisis según disponibilidad).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 60 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 60 años presenta dolor precordial, irradiado al cuello, de 4 horas de evolución, EVA 9/10. Al examen físico está sudoroso, disneico, con RR2T, sin soplos. Se solicita un ECG que se muestra a continuación: ¿Cuál es el tratamiento más importante en este paciente?

A) Anticoagulantes
B) Revascularización inmediata
C) Administración de fuidos intravenosos
D) Disminuir la presión arterial
E) Oxigenoterapia y antiarrítmicos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Revascularización inmediata** (opción **B**). Es un IAM con SDST de la pared inferior. Los más importante es revascularizar.. El tratamiento es carga de volumen agresiva para mantener precarga del VD De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 125 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente está hospitalizado por un infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, de dos días de evolución. Presenta deterioro del estado general y disnea de reposo, con tendencia a la hipotensión arterial. En su examen físico tiene FC: 115x', PA: 80/50 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales intensos y examen cardíaco con ritmo regular en 2 tonos, con soplo sistólico intenso, de localización precordial. El diagnóstico más probable es:

A) Taponamiento cardíaco por rotura de la pared libre
B) Disfunción valvular aórtica isquémica
C) Rotura del músculo papilar
D) Shock cardiogénico por infarto masivo
E) Disección de la raíz aórtica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una rotura clásica del músculo papilar con la insuficiencia mitral secundaria. Insisto, lean el resumen de semiología cardíaca.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 87 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un hombre de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo, consulta por dolor torácico opresivo de 3 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, acompañado de náuseas y malestar general. Al ingreso, sus signos vitales son: presión arterial 140/85 mmHg, frecuencia cardíaca 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 96% con aire ambiente, y temperatura 36,8 °C. El examen cardiopulmonar muestra ruidos cardíacos regulares sin soplos y campos pulmonares limpios sin crépitos ni sibilancias. Se solicita electriocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: www.urgenciasyemergen.com): La conducta más adecuada es:

A) Solicitar angioTAC de tórax
B) Solicitar enzimas cardíacas seriadas
C) Realizar angiografía coronaria de emergencia
D) Anticoagular con heparina y solicitar ecocardiograma transesofágico
E) Iniciar indometacina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome Coronario Agudo con Bloqueo de Rama Izquierda: El cuadro clínico sugiere un síndrome coronario agudo. El ECG muestra un BCRI, por lo que se maneja como un SCA con supradesnivel del ST, con angiografía coronaria de urgencia y angioplastia o con trombólisis urgente si la angioplastia no está disponible.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 145 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 67 años, usuario de sildenafil, que se automedica como tratamiento de impotencia sexual, presenta dolor torácico intenso, que inició una hora después de haber consumido dicho medicamento. Se solicita un electrocardiograma, que muestra suprdesnivel del segmento ST en las derivaciones inferiores. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A) Clopidogrel
B) Aspirina
C) Atenolol
D) Nitroglicerina
E) Estreptoquinasa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La opción correcta es la **D** (Nitroglicerina). En este escenario clínico, nitroglicerina se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 60 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor precordial opresi- vo intenso, EVA: 9/10, asociado a malestar general y disnea. Al examen físico con fre- cuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 150/90 mmHg, al examen cardia- co se ausculta un ritmo regular y tercer ruido. Se realiza estudio con electrocardiogra- ma que muestra supradesnivel del segmento ST en DII, DIII y AVF. Diagnóstico más pro- bable:

A) Infarto de pared anterior
B) Infarto de pared inferior
C) Pericarditis
D) Infarto de pared posterior
E) Infarto de pared lateral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Infarto de pared inferior** (opción **B**). DII, DIII y AVF son las derivaciones inferiores.. El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 55 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Paciente de 63 años, fumador y diabético, que hace una hora comienza con dolor torácico opresivo, intenso, que se irradia a cuello, con diaforesis y sensación de angustia. Se solicita un electrocardiograma, que muestra ritmo sinusal, a 80 lpm, con bloqueo completo de rama izquierda, que no se había visualizado en electrocardiogramas previos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar enzimas cardíacas
B) Solicitar angiografía pulmonar
C) Solicitar ecocardiograma transesofágico
D) Instalar marcapaso externo transitorio
E) Iniciar terapia de reperfusión miocárdica precoz

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El BCRI nuevo es equivalente al SDST en el manejo del infarto, así que se debe reperfundir de inmediato, idealmente con angioplastía (o bien con trombolisis si no está disponible la angioplastía en menos de 90 minutos).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 42 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 60 años consulta por dolor precordial opresivo irradiado a mandíbula de 40 minutos de evolución, asociado a sudoración. El electrocardiograma muestra supradesnivel del segmento ST en derivaciones DII, DIII y aVF. ¿Cuál es la principal complicación temprana de este cuadro?

A) Insuficiencia mitral aguda.
B) Rotura de pared libre.
C) Arritmias ventriculares.
D) Taponamiento cardíaco.
E) Fibrilación auricular.

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es un cáncer de laringe, que se estudia con nasofibroscopía, o bien, con la laringoscopía directa, para tomar biopsias.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 11 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso en tratamiento con dieta, consulta por dolor torácico incitrante, intenso, asociado a sudoración y malestar general. Al examen físico está sudoroso, inquieto, con FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, RR2T sin soplos. Se solicita un electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Qué tratamiento se debe indicar en este momento?

A) Aspirina y clopidogrel
B) Lidocaína y heparina
C) Morfina y nitritos
D) Atenolol e hidroclorotiazida
E) Digoxina y enalapril

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Aspirina y clopidogrel** (opción **A**). Es un síndrome coronario agudo. El BCRI es equivalente a un SDST.. El tratamiento es carga de volumen agresiva para mantener precarga del VD De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 157 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

ECG con supra st DII, DIII y aVF- medida inicial más adecuada:

A) Reperfusión
B) Doble antiagregación (PORQUE NO PODRÍA SER)
C) Insuficiencia cardíaca
D) Fibrilación auricular
E) Infarto agudo al miocardio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Reperfusión). El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 44 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 23 años consulta en el servicio de urgencia, por dolor torácico de 2 horas de evolución, intenso, asociado a diaforesis y palpitaciones, que inició algunos minutos después de haber inhalado cocaína. Al examen físico presenta FC: 120x', PA: 190/120 mmHg, ritmo regular en dos tonos, sin soplos. Su electrocardiograma muestra supradesnivel de segmento ST en las derivaciones de la pared anterior. ¿Qué fármaco está contraindicado en el manejo de este paciente?

A) Estreptoquinasa
B) Clopidogrel
C) Nitroglicerina
D) Atenolol
E) Diazepam

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El betabloqueo está contraindicado en la intoxicación por cocaína, ya que su esto exacerbaría su acción alfa-adrenérgica, pudiendo generar crisis hipertensivas y muerte. Lo que sí está indicado son las benzodiacepinas.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 96 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Paciente con IAM con SDST llega a hospital sin capacidad de angioplastia primaria. El centro con ICPP más cercano se encuentra a 60 minutos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Trombolisis inmediata y traslado a centro con hemodinamia
B) Esperar traslado a centro con angioplastia
C) Angioplastia de rescate de urgencia en el mismo centro
D) Manejo médico solo con heparina y AAS
E) Trombolisis y no trasladar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
IAM SDST sin capacidad de ICPP: si el traslado a centro con angioplastia demora >120 min desde el primer contacto médico, se realiza trombolisis inmediata + traslado para angiografía en 3-24h.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 28 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión de larga data, mal controlado, consulta por un cuadro de disnea, opresión precordial y malestar general que comenzó hace dos horas. Al examen físico tiene FC: 88 lpm, PA: 220/120 mmHg y se ausculta ritmo regular en dos tiempos sin soplos y murmullo pulmonar presente bilateral, con escasos crépitos basales. Se solicita electrocardiograma que muestra desnivel de 2 milímetros en las derivaciones precordiales izquierdas. ¿Cuál es el fármaco de elección para el control de su presión arterial?

A) Nitroprusiato endovenoso en infusión continua
B) Nitroglicerina endovenosa en infusión continua
C) Captopril vía oral
D) Hidralazina endovenosa
E) Nifedipino sublingual

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Manejo de la hipertensión en el síndrome coronario agudo: El paciente presenta un síndrome coronario agudo con aparente supradesnivel del ST y una crisis hipertensiva con daño a órgano blanco, lo que la clasifica como emergencia hipertensiva. En el contexto de un infarto, la nitroglicerina endovenosa suele ser el fármaco hipotensor de elección. En otras emergencias hipertensivas, como la disección aórtica, se suele utilizar labetalol o nitroprusiato por vía intravenosa.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 3 1.01.2.004 · Infarto agudo al miocardio

Los enunciados fueron algo más cortos que los de las últimas versiones.

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (No se dispone de información suficiente). Tiene un SCA con un BCRI reciente, por lo que debe ser manejado igual que un SCA con SDST.. El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 61 1.01.4.005 · Cintigrafía de perfusión m

¿Cuál es el mejor examen para determinar si una insuficiencia cardiaca es de origen isquémico?

A) Electrocardiograma
B) Holter de electrocardiograma
C) Contigrafia de perfusión miocárdica
D) Ecografía bidimensional
E) Test de esfuerzo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
D? La verdad es que tanto la Ecocardiografía, como la Cintigrafía de perfusión son útiles para determinar la etiología isquémica de una ICC. La Ecocadiografía verá zonas hipoquinéticas y necrosadas o fibrosadas. La cintigrafía verá las zonas que se isquemizan con la actividad física.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 65 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un paciente de 85 años, hipertenso, está en tratamiento con losartan 50 mg/12 horas y amlodipino 2,5 mg/día. Acude a control y refiere múltiples tomas de presión arterial, las que promedian 145/75 mmHg ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de losartán a 100 mg/12 horas
B) Aumentar el amlodipino a 5 mg/día
C) Agregar atenolol 12,5 mg/día
D) Agregar hidroclorotiazida 25 mg/día
E) Mantener el tratamienti

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener el tratamienti** (opción **E**). Por su edad, está bien controlado, ya que la meta es que sea menor a 150/90 mmHg.. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 177 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un paciente de 45 años, con IMC de 32 kg/m², acude a control médico, obje8vándose presión arterial de 146/92 mmHg. Se solicita Holter de presión arterial, que muestra múl8ples registros sobre 140/90 mmHg, diagnos8cándose hipertensión arterial. Sus exámenes de laboratorio resultan normales, incluyendo función renal, electrolitos plasmá8cos y electrocardiograma. ¿Qué 8po de fármacos es el más adecuado para iniciar el tratamiento an8hipertensivo en este paciente?

A) Bloqueadores alfa-adrenérgicos
B) Bloqueadores beta-adrenérgicos
C) Inhibidores del canal de calcio
D) Antagonistas del receptor de angiotensina
E) Diuré2cos 2azídicos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Además de obesidad, con alta probabilidad Gene una hipertensión esencial, ya que no Gene elementos que hagan sospechar una causa secundaria. En pacientes jóvenes se suele iniciar con IECA (inhibidores de la enzima converGdora de angiotensina) o ARA2 (antagonistas del receptor de angiotensina 2). Muchas guías actuales prefieren iniciar con dos fármacos de forma simultánea (ej. losartán + amlodipino). Aunque IECA y ARA2 Genen resultados comparables, muchos pacientes prefieren el losartán sobre el enalapril, debido a que se toma una vez al día.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 32 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Hombre de 55 años hipertenso en tratamiento con enalapril, bien controlado. Consulta por tos seca persistente desde que inició el tratamiento hace 3 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amlodipino (mantener enalapril y agregar calcioantagonista)
B) Hidroclorotiazida (agregar diurético)
C) Losartán (cambiar enalapril por ARA II)
D) Atenolol (agregar betabloqueador)
E) Suspender enalapril sin reemplazar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tos seca por IECA (enalapril): efecto de clase por acumulación de bradicinina, ocurre en 10-15% de pacientes. Solución: cambiar a ARA II (Losartán, Valsartán) que no causan tos. El control hipertensivo se mantiene con igual eficacia sin el efecto adverso.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 85 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Paciente con HTA en triple terapia (IECA, amlodipino, HCTZ), con edema en extremidades inferiores y presión 120/70. ¿Cuál es la conducta?

A) Agregar furosemida oral
B) Suspender amlodipino
C) Reducir dosis de IECA
D) Agregar espironolactona
E) Derivar a cardiología por insuficiencia cardíaca

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suspender amlodipino** (opción **B**). Suspender amlodipino. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 180 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Paciente con HTA sobre el rango normal en tratamiento actual, ¿cuál es el medicamento más adecuado a agregar?

A) Amlodipino
B) Valsartán (ARA II)
C) Hidroclorotiazida
D) Carvedilol
E) Furosemida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Valsartán (ARA II)** (opción **B**). Valsartán (ARA II). IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 122 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un paciente de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con aspirina, losartán, amlodipino, hidroclorotiazida y metformina, consulta por sensación de hinchazón y molestias en las extremidades inferiores. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender el amlodipino
B) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
C) Disminuir la dosis de metformina
D) Suspender el losartán
E) Aumentar la dosis de aspirina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El edema de EEII hace que probablemente sea un efecto adverso del amlodipino, por lo que se debe suspender.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 51 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Una paciente de 67 años, hipertensa, en tratamiento con losartán 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlodipino 5 mg, carvedilol 12,5 mg. Presenta edema de las extremidades inferiores, que ha ido en aumento. En su examen físico tiene FC: 57x' regular, con PA: 130/90 mmHg, RR2T, examen pulmonar sin alteraciones y examen abdominal con hígado palpable 1 cm bajo el reborde costal y extremidades inferiores con edema bimaleolar con signo de la fóvea. La conducta más adecuada es:

A) Reforzar la dieta hiposódica e indicar reposo con las extremidades en alto
B) Suspender el amlodipino
C) Subir la dosis del diurético
D) Suspender el losartán y agregar doxazosina
E) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En este caso tiene un efecto adverso del amlodipino: edema, por lo que que hay que suspenderlo. Aunque la A y la C podrían servir, se debe siempre suspender y reemplazar el medicamento que produzca un efecto adverso, en la medida de lo posible, antes de tomar otras medidas (esto aplica para medicina en general).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 14 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Una paciente de 53 años, diabética tipo 2, es diagnosticada recientemente de hipertensión. Sus exámenes generales, incluyendo un electrocardiograma, no muestran alteraciones ¿Qué fármaco es más adecuado para su tratamiento?

A) Atenolol
B) Hidroclorotiazida
C) Carvedilol
D) Amlodipino
E) Enalapril

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por ser menor de 55 años, como especialmente por ser diabética, el antihipertensivo de elección son los IECAs (enalapril).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 9 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un paciente de 63 años, diabético y dislipidémico, en tratamiento con metformina, atorvastatina y aspirina, se realiza varias tomas de presión arterial, que resultan 170/100 mmHg en promedio. Se realiza exámenes que muestran creatinina: 1,1 mg/dl, proteinuria (+), glucosuria (++), potasemia: 4,0 mEq/L, natremia: 142 mEq/L, glicemia: 115 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar amlodipino
B) Iniciar hidroclorotiazida
C) Iniciar enalapril
D) Iniciar hidralazina
E) Iniciar atenolol

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar enalapril** (opción **C**). La HTA en un diabético se trata con IECAs como primera línea. También la proteinuria.. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 86 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Adulto mayor hipertenso con cardiopatía coronaria, en tratamiento con carvedilol, atorvastatina e HCTZ, presiones elevadas con función renal y potasio normales. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amlodipino
B) Hidralazina
C) Metildopa
D) Nifedipino de liberación prolongada
E) Losartán

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Losartán** (opción **E**). Losartán. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 78 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Paciente HTA en tratamiento con atenolol e hidroclorotiazida, metas fuera de rango con proteinuria que hipotensor es el indicado: a. Enalapril.

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Amoxicilina** (opción **A**). IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 105 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un paciente de 56 años, diabético en tratamiento con metformina 500 mg/8horas, con hipertensión de reciente diagnóstico, se realiza exámenes de control, que muestran creatinina plasmática: 0,9 mg/dl, BUN: 18 mg/dl, electrolitos plasmáticos: Na+: 141 mEq/L y K+: 4,1 mEq/l, RAC (relación albuminuria / creatininuria): 2,6 y hemoglobina glicosilada: 6,9%. ¿Qué fármaco es el más adecuado para el tratamiento de su hipertensión arterial?

A) Hidralacina
B) Espironolactona
C) Amlodipino
D) Atenolol
E) Valsartán

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Atenolol** (opción **D**). Clase sobre las familias de antihipertensivos, sus efectos adversos, contraindicaciones y criterios de elección. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 144 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un paciente diabético de larga data en tratamiento con empagliflozina 10 mg al día, metformina 1.000 mg cada 8 horas y atorvastatina 20 mg al día, presenta presiones arteriales de 140/90 mmHg y 158/87 mmHg en dos controles diferentes. El resto de su examen físico es normal y trae exámenes, entre los que destaca hemoglobina glicosilada de 6.9%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar terapia depletiva de potasio
B) Iniciar tratamiento antihipertensivo
C) Solicitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
D) Iniciar terapia antiagregante plaquetaria
E) Iniciar insulina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hipertensión en Paciente Diabético: Aunque se recomiendan tres tomas de presión arterial o un monitoreo ambulatorio de 24 horas para diagnosticar hipertensión, dos tomas pueden ser suficientes en pacientes diabéticos si hay alta sospecha. El objetivo de presión arterial en estos pacientes es menor a 130/80 mmHg, por lo que está claramente sobre esos valores. El tratamiento inicial recomendado en diabéticos son los antihipertensivos IECA o ARA II.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 36 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Una paciente de 60 años con antecedente de hipertensión arterial de larga data, en tratamiento con carvedilol 25 mg cada 12 horas e hidroclorotiazida 50 mg/día, presenta presiones arteriales cercanas a 150/95 en la mayoría de las tomas. Además, tiene disnea de grandes esfuerzos y ortopnea, que lo obliga a dormir con una almohada grande. Su examen físico tiene frecuencia cardíaca 66x', PA: 150/96 mmHg, saturación arterial de oxígeno de 97%, examen pulmonar con crepitaciones bibasales, sin otras alteraciones y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicitan exámenes que muestran natremia: 142 mEq/L, potasemia: 4,0 mEq/L, creatininemia: 0,7 mg/dl, con hemograma y pruebas tiroideas normales. ¿Qué fármaco debería agregarse en este caso?

A) Losartán
B) Amlodipino
C) Verapamilo
D) Diltiazem
E) Doxazosina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Doxazosina** (opción **E**). IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 92 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina y enalapril, consulta por tos seca de 3 meses de evolución. Al examen físico tiene murmullo pulmonar conservado bilateral, sin presencia de otros ruidos. Su radiografía de tórax se muestra a continuación: La conducta inicial más adecuada es:

A) Suspender la metformina
B) Iniciar salbutamol
C) Iniciar codeína
D) Suspender el enalapril
E) Solicitar prueba de provocación bronquial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un caso clásico de tos, como efecto adverso de los IECAs. Se deben suspender y reemplazar por un ARA2 (ej. losartán).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 134 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

122) Un paciente de 69 años, con antecedente de diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con aspirina, losartán, amlodipino, furosemida y metformina, consulta por sensación de molestias en las extremidades inferiores, las que describe como pesadas e hinchadas. Se aprecia en buenas condiciones generales, no tiene otros síntomas, sus presiones arteriales están dentro de rangos normales, al igual que su hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender el amlodipino
B) Aumentar la dosis de furosemida
C) Disminuir la dosis de metformina
D) Suspender el losartán
E) Aumentar la dosis de aspirina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suspender el amlodipino** (opción **A**). El amlodipino puede producir edema y malestar en las extremidades. Se debe suspender en ese caso.. IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 7 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Una paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con metforminal, glibenclamida, hidroclorotiazida y enalapril consulta por un cuadro de cefalea y malestar general. Refiere que sus presiones arteriales habituales son cercanas a 150/90 mmHg. Al examen físico presenta PA: 200/105 mmHg, FC: 73 x', con examen pulmonar normal. ¿Cuál es el tratamiento del cuadro actual?

A) Nifedipino sublingual
B) Nitroglicerina sublingual
C) Nitroprusiato endovenoso
D) Captopril oral
E) Labetalol endovenoso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El tratamiento de la crisis hipertensiva, sin compromiso de órgano banco (urgencia hipertensiva) es el captopril oral. Sin embargo, la evidencia es errática y permite usar otros antihipertensivos.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 38 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Un adulto mayor de 87 años, con antecedente de hipertensión arterial, está en tratamiento con amlodipino 5 mg/día, hidroclorotiazida 25 mg/día y enalapril 10 mg cada 12 horas, presenta presiones arteriales de control de 120/80 mmHg, sin embargo, consulta por edema y sensación de pesadez en sus extremidades inferiores. Al examen físico se objetiva edema moderado bilateral en los tobillos, signos vitales dentro de rango normal y examen cardiopulmonar normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Disminuir la dosis nocturna de enalapril
B) Reemplazar el enalapril por losartán
C) Suspender el amlodipino
D) Agregar furosemida al tratamiento
E) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida a 50 mg/día

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Reemplazar el enalapril por losartán** (opción **B**). IECA y ARA-2 son intercambiables; NO combinar; de elección en diabetes y proteinuria De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 6 1.01.1.015 · Hipertensión arterial esen

Una paciente de 61 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, diagnosticada hace 2 meses, momento en que inicia tratamiento con enalapril 10 mg/dl, metformina 850 mg cada 12 horas y dieta. Hace 4 semanas inicia tos, que ha ido en aumento, sin expectoración. Su examen físico muestra FC: 67 x', PA: 120/80 mmHg y su auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que la radiografía de tórax. La conducta más adecuada es:

A) Suspender el IECA
B) Agregar hidroclorotiazida
C) Solicitar espirometría
D) Agregar salbutamol
E) Agregar codeína

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La tos es la reacción adversa más frecuente de los IECA y es la razón principal para reemplazarlos por inhibidores de la angiotensina II. !

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 4 1.01.2.009 · Taqui y bradiarritmia con

Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos por minuto, regular y presión arterial de 70/40 mmHg. Además, tiene frialdad de extremidades y piel sudorosa. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado en este momento?

A) Maniobras vagales
B) Amiodarona endovenosa
C) Adenosina endovenosa
D) Desfibrilación
E) Cardioversión eléctrica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por tener compromiso hemodinámico, da igual de qué taquiarritmia se trate y se debe cardiovertir eléctricamente (no confundir con la desfibrilación, que se usa en el paro con FV o TVSP).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 177 1.01.2.009 · Taqui y bradiarritmia con

Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 2 años, presenta un síncope, con compromiso de conciencia que requirió maniobras de reanimación para recuperarse. ¿Qué arritmia es la que debe descartarse en primer lugar?

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Bloqueo auriculoventricular completo
C) Síndrome de Wolff Parkinson White
D) Taquicardia ventricular
E) Fibrilación auricular

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien cualquier arritmia se puede presentar así, el antecedente de un IAM previo orienta mucho a TV. Además, la TV suele ser más grave y letal que las demás, por lo que la necesidad de maniobras de reanimación orienta también a TV.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 93 1.01.2.009 · Taqui y bradiarritmia con

Un paciente hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, y con antecedentes de asma en tratamiento con inhaladores, consulta por palpitaciones, asociadas a disnea y angustia. Al examen físico se constata taquicardia con frecuencia cardíaca de 124 latidos por minuto y presión arterial de 80/40 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación (fuente: myekg.com): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Desfibrilación
B) Amiodarona endovenosa
C) Propranolol endovenoso
D) Adenosina endovenosa
E) Cardioversión eléctrica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Manejo de la Fibrilación Auricular Hemodinámicamente Inestable: En el caso de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida que cause inestabilidad hemodinámica, se debe realizar cardioversión eléctrica inmediata (no confundirla con la desfibrilación eléctrica, que se usa en el paro). Este manejo se aplica a cualquier tipo de taquiarritmia con hemodinamia inestable. Si la fibrilación auricular hubiera presentado una hemodinamia estable, el manejo inicial habría sido disminuir la frecuencia cardíaca con propranolol endovenoso.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 2 1.01.2.009 · Taqui y bradiarritmia con

Una paciente de 68 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, metformina y aspirina, consulta por un cuadro de palpitaciones, asociado a malestar general y disnea de reposo. Tiene frecuencia cardíaca irregular de 160 lpm, PA: 85/40 mmHg, extremidades pálidas y frías en la zona distal. Su electrocardiograma muestra una fibrilación auricular rápida. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Administrar amiodarona
B) Administrar verapamilo
C) Administrar heparina y clopidogrel
D) Realizar cardioversión eléctrica
E) Administrar nitritos y morfina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una FA con hemodinamia inestable y como toda taquiarritmia hemodinámicamente inestable, se debe cardiovertir, de inmediato.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 25 1.01.2.009 · Taqui y bradiarritmia con

Una paciente de 68 años, hipertensa de larga data, consulta por disnea de pequeños esfuerzos, fatigabilidad y palpitaciones irregulares. Al examen físico, su presión arterial es de 100/60 mmHg con frecuencia cardiaca de 130 latidos por minuto, irregular, ade- más, presenta ingurgitación yugular y crépitos pulmonares bilaterales. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO ¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

A) Verapamilo
B) Amiodarona
C) Lanantósido C
D) Heparina
E) Digoxina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta discutible, pero al estar algo hipotenso y en Shock cardiogénico, el verapamilo podría agravar el cuadro, por ser un bloqueador del calcio, que producen vasodilatación periférica (aunque el efecto del verapamilo en la circulación periférica es mínimo).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 92 1.01.2.009 · Taqui y bradiarritmia con

Hombre de 75 años que hace 4 años tuvo un infarto y actualmente presenta palpitaciones intensas y compromiso de conciencia que se recupera después de reanimación cardiopulmonar ¿Qué arritmia debe descartarse en primer lugar?

A) Fibrilación Auricular
B) Taquicardia Ventricular
C) Taquicardia paroxística supraventricular
D) Bloqueo A-V de segundo grado mobitz 1
E) Flutter auricular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
También podría haber sido una fibrilación ventricular, pero suelen estar precedidas por taquicardias ventriculares. Los infartos son la primera causa, porque se produce un fenómeno de reentrada alrededor de la zona ventricular infartada y por eso es frecuente la muerte súbita, al tener antecedente de un infarto.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 139 1.01.2.009 · Taqui y bradiarritmia con

Un paciente de 64 años, con antecedente de un infarto al miocardio de pared anterior, hace 1 año, consulta por dolor torácico y disnea de reposo de 40 minutos de duración, asociado a palpitaciones. Al examen físico presenta FC: 200x' y se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioteca.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Flutter auricular
C) Síndrome de Wolff Parkinson White
D) Taquicardia ventricular
E) Fibrilación auricular

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Taquicardia ventricular** (opción **D**). La taquicardia ventricular (TV) es una arritmia potencialmente letal que se origina por debajo del haz de His. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 21 1.01.1.002 · Bloqueos aurículo-ventricu

Un paciente de 62 años presenta malestar general marcado, desde hace 20 minutos. Al examen físico está sudoroso, tiene FC: 33x', PA: 120/50 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
B) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo I
C) Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo II
D) Bloqueo auriculoventricular de tercer grado
E) Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se observa con disociación AV y, además, la FC cercana a 30 sugiere mucho un BAV completo o de tercer grado. Se deben saber identificar todas las arritmias de manera relativamente rápido en el EKG.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 138 1.01.1.002 · Bloqueos aurículo-ventricu

Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de 3 meses de evolución. Además, presenta lipotimias luego de levantarse de la cama. Al examen físico tiene FC: 45 x', regular. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioparamap.com): El diagnóstico más probable es:

A) Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
B) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz I
C) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz II
D) Bloqueo aurículo-ventricular completo
E) Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un SHE confirmado (PA mayores o iguales a 140/90 por 6 horas), probablemente una preclamsia, por el edema de EEI!l. Su RBNE no reactivo aporta O puntos al PBF, más el OHA que también aporta O puntos. Con eso tiene un PBF máximo de 6/10 más OHA, por lo que es ominoso y se debe interrumpir. La vía de parto debe ser cesárea por el estado fetal y el riesgo de hipoxia durante el trabajo de parto. Los movimientos respiratorios y la postura adecuada dan 2 puntos cada uno. No se mencionan los movimientos fetales, que darían 2 puntos más.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 96 1.01.1.002 · Bloqueos aurículo-ventricu

Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de algunos días de evolución. Además, presenta lipotimias luego de levantarse de la cama. Al examen físico tiene FC: 48 x', regular. Se realiza un electrocardiograma, que se muestra a continuación: Foto 10 (https://cardioparamap.com/2016/12/09/XXXXXXXXXX/). El diagnóstico más probable es:

A) Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado
B) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz I
C) Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz II
D) Bloqueo aurículo-ventricular completo
E) Enfermedad del nodo sinusal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
[Pregunta disputada] Es un bloqueo AV de segundo grado, con bloqueo 2:1. Por lo tanto es imposible hacer la diferencia entre Mobitz I y II, por lo que es una mala pregunta. Yo marqué B.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 163 1.01.1.002 · Bloqueos aurículo-ventricu

¿Cuál es el diagnóstico que se visualiza en el siguiente electrocardiograma?

A) Bloqueo AV completo
B) Fibrilación auricular lenta
C) Bloqueo AV de 2do grado
D) Bradicardia sinusal
E) Paro sinusal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una imagen de un BAV de segundo grado, Mobitz I, en que se va alargando el PR, hasta que una onda P no conduce.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 117 1.01.1.002 · Bloqueos aurículo-ventricu

En un paciente adulto mayor, que presenta síncopes, ¿cuál de las siguientes arritmias requiere un marcapaso definitivo?

A) Fibrilación auricular crónica
B) Bloqueo auriculoventricular de primer grado
C) Flutter auricular 2-3 a 1
D) Enfermedad del nodo sinusal
E) Bloqueo completo de rama izquierda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La enfermedad del nodo sinusal, sintomática, requiere de marcapasos definitivo. El bloqueo AV requiere ser de tercer grado o de segundo grado Mobitz II, para ser indicación de marcapasos. El flutter y la FA se tratan farmacológicamente y no con marcapasos. El BCRI se observa.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 158 1.01.2.008 · Taponamiento pericárdico

Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:

A) Ecocardiograma
B) Hemograma y VHS
C) Ecografía
D) Radiografía
E) TAC con contraste

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Ecocardiograma** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Hemograma y VHS, Ecografía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 3 1.01.2.008 · Taponamiento pericárdico

Un paciente con antecedente de ser fumador de 30 paquetes año, suspendido hace 5 años, consulta por un cuadro de 24 horas de disnea de mínimos esfuerzos, asociada a intolerancia al ejercicio y malestar general. Al examen físico su PA: 90/60 y su FC: 110x'. Además destacan yugulares ingurgitadas a 45 grados y ruidos cardíacos apagados a la auscultación. Su electrocardiograma muestra disminución difusa del voltaje. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumotórax
C) Derrame pleural
D) Infarto agudo al miocardio
E) Taponamiento cardíaco

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Taponamiento cardíaco** (opción **E**). Es una clínica de taponamiento clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 136 1.01.2.008 · Taponamiento pericárdico

Un paciente de 79 años, con antecedente de cáncer de pulmón en espera de tratamiento, presenta un cuadro de 5 días de malestar general, disnea y episodios de pérdida de conocimiento de pocos segundos de duración, con recuperación completa. El examen físico muestra presión arterial: 80/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 110x' regular, cuello con ingurgitación yugular a 50 grados. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos agregados y la auscultación cardíaca es difícil de realizar, ya que los ruidos cardíacos se encuentran apagados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Taponamiento cardíaco
C) Derrame pleural
D) Síndrome de la vena cava superior
E) Insuficiencia tricuspídea

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Taponamiento Cardíaco: Aunque el antecedente de cáncer, la hipotensión y la disnea sugieren un tromboembolismo pulmonar, la disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos apunta a derrame pericárdico con taponamiento, también compatible con el antecedente de cáncer y el resto de la clínica. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 7 1.01.4.014 · Holter de ritmo

Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y acenocumarol, consulta porque presenta repetidos episodios de malestar, sudoración y ortostatismo, que duran algunos segundos y revierten espontáneamente. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 60 lpm, irregular y presión arterial 110/70 mmHg. Su examen cardiopulmonar es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Test de esfuerzo
B) Ecocardiograma
C) Ecografía doppler de extremidades inferiores
D) Tilt test
E) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es una enfermedad del nodo sinusal, en contexto de un síndrome taquicardia/bradicardia (FA + ENS).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 153 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina, atorvastatina, enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg al día, furosemida 40 mg cada 12 horas. Actualmente presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 65x', presión arterial: 110/70 mmHg, saturación de oxígeno del 96%; en el examen cardiopulmonar se auscultan crépitos pulmonares bibasales y ritmo cardíaco regular en dos tiempos, con un soplo sistólico III/VI. El choque de la punta es palpable en la línea axilar media y presenta edema en los miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada para este paciente?

A) Agregar losartán
B) Agregar hidralazina
C) Agregar isosorbide
D) Agregar espironolactona
E) Agregar amiodarona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Insuficiencia Cardíaca Congestiva: Los medicamentos que aumentan la supervivencia en la insuficiencia cardíaca congestiva son los IECA o ARA II, betabloqueantes (idealmente carvedilol) y espironolactona. El manejo de la patología de base también es fundamental. El losartán no se usa en este caso porque el paciente ya toma enalapril, que cumple la misma función.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 135 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con losartán, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por progresión de su disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 1 cuadra. Al examen físico, tiene edema de extremidades inferiores, se palpa el choque de la punta en la línea axilar media y se ausculta ritmo cardíaco regular, sin soplos, con crépitos bilaterales en la auscultación pulmonar. Se realiza ecocardiografía que muestra disfunción ventricular, con fracción de eyección de 23%. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

A) Losartán
B) Metformina
C) Aspirina
D) Nifedipino
E) Hidroclorotiazida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El nifedipino puede agravar una insuficiencia cardíaca, por sus efectos inotrópicos negativos, por lo que en este caso, en que el paciente está descompensado, se debe suspender. Se debería agregar betabloqueo (con cuidado, iniciando dosis bajas) y, por la baja fracción de eyección (menor a 35%), probablemente se agregará espironolactona también, para aumentar la sobrevida (también el betabloqueo).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 10 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Un hombre de 66 años, hipertenso e insuficiente cardíaco, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por disnea de grandes esfuerzos, asociada a ortopnea de 2 almohadas y escaso edema de extremidades inferiores. Su electrocardiograma tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál fármaco es más importante agregar?

A) Isosorbide
B) Carvedilol
C) Losartán
D) Furosemida
E) Hidroclorotiazida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Carvedilol** (opción **B**). El betabloqueo aumenta la sobrevida. El losartán también, pero estaba con enalapril.. Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 1 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Mujer de 68 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (FEVI 35%), clase funcional NYHA III. En tratamiento con furosemida y enalapril. ¿Cuál es el diurético que se debe agregar para mejorar el pronóstico?

A) Hidroclorotiazida
B) Indapamida
C) Clortalidona
D) Espironolactona
E) Torasemida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Espironolactona (antagonista de aldosterona) reduce la mortalidad en ICC con FEVI ≤35% y NYHA III-IV (estudio RALES). Se agrega a furosemida + IECA. Monitorizar kalemia y función renal.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 123 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Un paciente de 71 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con enalapril, metformina, aspirina, nifedipino e hidroclorotiazida consulta por disnea de esfuerzos, que aparece al caminar 2 cuadras. Al examen físico, se palpa el choque de la punta desplazado 2 cm hacia lateral y se ausculta ritmo cardíaco regular, en tres tiempos, con presencia de un tercer ruido y de un soplo de insuficiencia mitral III/VI, con escasos crépitos en la auscultación pulmonar. ¿Qué fármaco debe suspenderse?

A) Enalapril
B) Metformina
C) Aspirina
D) Nifedipino
E) Hidroclorotiazida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Nifedipino** (opción **D**). La ICC con disfunción sistólica contraindica el nifedipino. Pregunta difícil.. Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 93 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Un paciente masculino, de 69 años, con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, con cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina consulta por mayor disnea de la habitual, la que limita sus actividades de la vida diaria, asociada a ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico su PA: 130/80 mmHg, FC: 70x', se observa edema de extremidades inferiores y se auscultan crepitaciones pulmonares escasas, en ambas bases. El examen cardiaco demuestra un choque de la punta en el 5° espacio intercostal, con auscultación normal. Se inicia tratamiento con carvedilol y furosemida, sin mayor respuesta. ¿Qué fármaco es más importante agregar al tratamiento de este paciente?

A) Isosorbide
B) Hidralazina
C) Atorvastatina
D) Espironolactona
E) Digoxina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La espironolactona aumenta la sobrevida en la insuficiencia cardíaca (no era necesario un enunciado tan grande para preguntar eso).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 8 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Un paciente de 50 años, con antecedente de miocardiopatía dilatada, en tratamiento con enalapril, carvedilol y furosemida, presenta disnea que aparece al realizar esfuerzos moderados, asociado a ortopnea. Su examen físico demuestra desplazamiento del choque de la punta, con crepitaciones de ambas bases pulmonares. Además se solicita una ecocardiografía que muestra una fracción de eyección de 24%. ¿Qué cambio recomendaría a este paciente?

A) Reemplazar la furosemida por hidroclorotiazida
B) Reemplazar el enalapril por losartán
C) Reemplazar el carvedilol por atenolol
D) Agregar hidralazina
E) Agregar espironolactona

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Agregar espironolactona** (opción **E**). La espironolactona aumenta la sobrevida en la ICC.. Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 13 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Una paciente de 40 años, con antecedente de asma e insuficiencia cardíaca, consulta por aumento de su disnea basal, por lo que se realizan algunos exámenes. Se solicita una ecocardiografía, que muestra cardiomegalia, con paredes finas y una fracción de eyección ventricular de 28%. Además se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina: 1,8 mg/dl, Na: 140 mEq/L, K: 3,8 mEq/L, Cl: 106 mEq/L. ¿Qué fármaco está contraindicado en esta paciente?

A) Enalapril
B) Losartán
C) Furosemida
D) Espironolactona
E) Digoxina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El asma contraindica los betabloqueantes. La IRC y la caída en la fracción de eyección contraindican los digitálicos.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 151 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Mujer fumadora, hipertensa, con historia de ICC, pero que ahora estaba como desde hace unos 3 meses con disnea de esfuerzo, y al examen pulmonar estaba con sibilancias espiratorias. Preguntaban por la causa del empeoramiento de los síntomas.

A) TEP
B) Fibrosis pulmonar
C) IC
D) Cor pulmonale
E) Hemograma y VHS

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (IC). Clase sobre el manejo de la hiperpotasemia e hipopotasemia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (TEP, Fibrosis pulmonar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 109 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

IC en tratamiento con carvedilol e hidroclorotiazida, con HTA de reciente dg, Na normal, K en 4.0 , que fármaco se debe agregar:

A) Diltiazem b. Losartán
C) BB
C) Amoxicilina
D) Ibuprofeno
E) Paracetamol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Diltiazem b. Losartán** (opción **A**). Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 5 1.01.1.018 · Insuficiencia cardíaca

Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con enalapril, metformina y digoxina, consulta por un cuadro de una semana de evolución de náuseas, asociadas a aumento de su disnea habitual. Al examen físico presenta FC: 114 lpm, regular, edema de extremidades inferiores y al examen pulmonar presenta crepitaciones en ambas bases pulmonares. El examen más adecuado para proseguir el estudio en este paciente es:

A) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas.
B) Niveles plasmáticos de digoxina
C) Ecocardiografía
D) Clearence de creatinina
E) Radiografía de tórax

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Niveles plasmáticos de digoxina** (opción **B**). Por las náuseas, más la descompensación de la insuficiencia cardíaca, parece una intoxicación digitálica.. Tratamiento de hiperpotasemia severa: primero gluconato de calcio (estabiliza membrana), luego insulina + glucosa (ingresa K a las células) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 70 1.01.1.007 · Endocarditis infecciosa y

Un paciente de 45 años, consulta por fiebre de 3 semanas de evolución sin otros sín- tomas. Al examen físico tiene temeratura 37,8°C, frecuencia cardiaca de 92 por minuto, con presión arterial 120/80mmHG. Al examen cardiaco se ausulta un soplo sistólico en ápex irradiado a dorso. En sus exámenes destacan leucocitos de 12.000/mm3 y PCR 9,6 (valor normal menor a 1,0). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Ecocardiografía bidimensional
B) Resonancia magnética cardiaca
C) Radiografía de tórax
D) AngioTAC de tórax
E) TAC de tórax abdomen y pelvis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se sospecha un endocarditis bacteriana subaguda (mayor a 7 días), por lo que se debe pedir hemocultivos y ecocardiografía.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 63 1.01.1.007 · Endocarditis infecciosa y

Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general, fiebre hasta 39 grados celsius. Al examen físico tiene un soplo pansistólico III/VI en el precordio izquierdo, además de apreciarse petequias en los pulpejos y alguna petequias subconjuntivales. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico etiológico?

A) Ecocardiograma
B) Hemocultivos
C) Hemograma
D) Coronariografía
E) ANA y complemento

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una endocarditis subaguda. Como se pregunta el diagnóstico etiológico, la respuesta son los hemocultivos. Sin embargo, la ecocardiografía, también es un examen importante.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 120 1.01.2.006 · Paro cardiorespiratorio

Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Desfibrilación inmediata sin RCP previa
B) Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Administrar adrenalina 1 mg EV de inmediato
E) Acceso venoso y carga de volumen

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)** (opción **B**). Iniciar compresiones torácicas externas (RCP). Actualmente no se diferencia el manejo entre agua salada y agua dulce. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 55 1.01.2.006 · Paro cardiorespiratorio

Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 20 paquetes año, consulta en el servicio de urgencia, por dolor precordial opresivo. Luego de su ingreso, presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen físico no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta inicial más adecuada es:

A) Realizar compresiones toráxicas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Dar golpe toráxico
D) Desfibrilar
E) Administrar adrenalina endovenosa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque se trate de un paro presenciado, que clásicamente se manejaba con desfibrilación inmediata, aquello solo ocurre cuando, además, está monitorizado, con desfibrilador a mano y se constata que tiene un ritmo desfibrilable de inmediato. De lo contrario, como en este caso (y la mayoría de los casos reales) siempre se debe solicitar ayuda e inmediatamente iniciar con las compresiones torácicas, mientras llega el resto del equipo con el desfibrilador y el carro de paro (con adrenalina, amiodarona, vías venosas, tubo orotraqueal, laringoscopio, etc.).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 35 1.01.2.006 · Paro cardiorespiratorio

Un paciente de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, dia- betes mellitus tipo 2 y tabaquismo de 50 paquetes año, consulta por dolor precordial opresivo y durante la anamnesis presenta compromiso de conciencia, sin respuesta. Al examen no respira y es imposible palpar el pulso carotídeo. Además de solicitar ayuda, la conducta más adecuada es:

A) Realizar compresiones toráxicas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Dar golpe toráxico
D) Administrar adrenalina intracardiaca
E) Realizar angioplastia de urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un paro, por lo que se debe iniciar RCP. Sin embargo, por ser un paro presencia- do, está indicado poner primero el desfibrilador, aunque no estaba en las opciones.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 128 1.01.1.010 · Estenosis mitral

Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78 lpm, presión arterial: 130/80 mmHg, examen pulmonar con murmullo vesicular conservado y presencia de crépitos bibasales, examen cardíaco con ritmo irregular en dos tiempos, con presencia de soplo diastólico. Se palpa el choque de la punta en el quinto espacio intercostal línea medioclavicular y se observa edema en extremidades inferiores con signo de la fóvea. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica
B) Estenosis pulmonar
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Insuficiencia pulmonar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Estenosis Mitral: El cuadro clínico es compatible con estenosis mitral. Se recomienda repasar la semiología cardíaca.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 158 1.01.1.010 · Estenosis mitral

Un paciente de 58 años presenta disnea de medianos esfuerzos y astenia. Al examen físico tiene FC: 70 lpm, PA: 120/80 mmHg, examen cardíaco con choque de la punta en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular y auscultación con un soplo diastólico. Al examen pulmonar se constata murmullo pulmonar presente, con crepitaciones basales escasas. Su electrocardiograma muestra fibrilación auricular, con respuesta ventricular de 70 latidos por minuto. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Insuficiencia aórtica
C) Estenosis tricuspídea
D) Estenosis mitral
E) Comunicación interventricular

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una estenosis mitral clásica (soplo diastólico, se asocia a FA y tiene VI de tamaño normal, con crecimiento de la Al). Ver resumen de semiología cardíaca.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 80 1.01.1.010 · Estenosis mitral

Una paciente de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril, consulta por disnea de esfuerzo que ha empeorado en el último tiempo

A) Estenosis mitral
B) Estenosis aórtica
C) Miocardiopatía hipertrófica
D) Insuficiencia aórtica
E) Cardiopatía hipertensiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Estenosis mitral** (opción **A**). Es una estenosis mitral clásica, con FA y todo.. La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en adultos mayores de países desarrollados De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 71 1.01.1.017 · Insuficiencia aórtica

Pregunta 71 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:

A) Insuficiencia tricuspídea
B) Estenosis aórtica
C) Insuficiencia aórtica
D) Estenosis mitral
E) Insuficiencia mitral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Insuficiencia aórtica** (opción **C**). Es una insuficiencia aórtica clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 147 1.01.1.017 · Insuficiencia aórtica

Adulto con disnea de esfuerzos progresiva, diferencia PA sistólica-diastólica amplia, pulsos amplios y soplo diastólico aspirativo. ¿Diagnóstico más probable?

A) Estenosis aórtica severa
B) Estenosis mitral con hipertensión pulmonar
C) Insuficiencia aórtica
D) Insuficiencia mitral crónica
E) Comunicación interventricular del adulto

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Insuficiencia aórtica** (opción **C**). Insuficiencia aórtica. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 2 1.01.1.017 · Insuficiencia aórtica

Un paciente masculino de 23 años, sin antecedentes de importancia consulta por disnea de esfuerzos e intolerancia al ejercicio, progresiva, que actualmente le obligan a caminar más lento. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 150/55 mmHg, choque de la punta en la línea axilar media y latido cervical visible. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular, en dos tiempos, con un soplo diastólico IV/VI, con frémito. Al examen pulmonar, se constatan crépitos pulmonares. El diagnóstico más probable es:

A) Insuficiencia mitral
B) Estenosis aórtica
C) Estenosis mitral
D) Insuficiencia aórtica
E) Miocardiopatía hipertrófica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Insuficiencia aórtica** (opción **D**). Es una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 91 1.01.1.017 · Insuficiencia aórtica

Un paciente de 18 años, con antecedente de coartación aórtica, operada en la infancia, consulta por disnea de esfuerzos, que ha ido en aumento, desde hace 2 meses. Además, refiere edema de extremidades inferiores y palpitaciones ocasionales. Al examen físico tiene FC: 88x', PA: 155/55 mmHg, el choque de la punta se palpa hiperdinámico, en la línea media axilar y en la auscultación cardíaca se constata soplo sistólico eyectivo II/VI, más un soplo diastólico III/VI, que dura toda la diástole. Su examen pulmonar muestra crépitos escasos en ambas bases. El diagnóstico más probable es:

A) Estenosis aórtica
B) Insuficiencia aórtica
C) Recoartación aórtica
D) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
E) Miocardiopatía dilatada

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Insuficiencia aórtica** (opción **B**). También era una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 137 1.01.1.014 · Flutter auricular

Un paciente de 71 años, con antecedente de reemplazo valvular tricuspídeo, secundario a una endocarditis bacteriana, con prótesis biológica in situ consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma (fuente: slideshare): El diagnóstico más probable es:

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación auricular
C) Flutter auricular
D) Síndrome de Wolff Parkinson White
E) Taquicardia auricular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En las últimas dos derivaciones se ven claramente las ondas de serrucho (que aparecen con la maniobra vagal, ya que bradicardiza y aumenta el bloqueo AV), características del flutter.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 95 1.01.1.014 · Flutter auricular

Un paciente de 40 años, con antecedente de reemplazo valvular, secundario a una endocarditis bacteriana, consulta por consulta por palpitaciones muy intensas, asociadas a disnea. Al examen físico tiene un pulso a 140 latidos por minutos, regular. Se realizan maniobras vagales (masaje carotídeo) y se observa el siguiente electrocardiograma: Foto 9 (https://www.slideshare.net/XXXXchandrabarik/svtalogarythm). El diagnóstico más probable es:

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación auricular
C) Flutter auricular
D) Síndrome de Wolff Parkinson White
E) Taquicardia auricular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Con las maniobras vagales baja la frecuencia, se ven las ondas de serrucho y luego vuelve a aumentar la frecuencia. Es lo clásico del flutter auricular.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 180 1.01.1.014 · Flutter auricular

Una paciente de 44 años, con antecedente de estenosis mitral consulta por palpitaciones rápidas, intensas, regulares, asociadas a disnea y malestar general. Se realiza masaje carotídeo, observándose el siguiente trazado en el electrocardiograma: Fuente: https://empendium.com/manualmibe/chapter/B34.II.2.6.7. El diagnóstico más probable es:

A) Taquicardia paroxística supraventricular
B) Fibrilación ventricular
C) Taquicardia sinusal
D) Flutter auricular
E) Taquicardia ventricular

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Flutter auricular** (opción **D**). Es un flutter o aleteo auricular clásico, con las ondas de serrucho.. El flutter auricular es una taquicardia supraventricular producida por un circuito de macrorreentrada auricular, más frecuentemente en la aurícula derecha alrededor del anillo tricuspídeo (flutter típico). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 81 1.01.1.016 · Hipertensión arterial secu

Paciente con HTA en tratamiento triple (enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida) con presiones elevadas persistentes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar dosis de enalapril al máximo
B) Agregar beta-bloqueador oral
C) Suspender hidroclorotiazida y agregar furosemida
D) Derivar a nefrología de urgencia
E) Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria** (opción **E**). Agregar espironolactona e iniciar estudio de HTA secundaria. Tratamiento: corticoides orales (detener avance) + cirugía vascular (desobstruir arterias) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 51 · 1.01.1.016 · Hipertensión arterial secu

Un paciente de 40 años, con antecedente de hipertensión arterial diagnosticada hace 6 meses, de difícil manejo, acude a control. Toma hidroclorotiazida 50 mg/día, losartán 100 mg/día y amlodipino 10 mg/día. Refiere varias crisis hipertensivas, a pesar de una buena adherencia a su tratamiento farmacológico. En el examen físico, su presión arterial actual es 158/97, que es similar a los valores que habitualmente presenta en su casa; su frecuencia cardíaca es 65x' y su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos y murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Trae un monitoreo de presión arterial con presión arterial promedio de 160/101 mmHg, con que muestra cargas tensionales diurnas de 77% sistólica y 63% diastólica y cargas tensionales nocturnas de 67% sistólica y 56% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reemplazar el losartán por un IECA
B) Reemplazar la hidroclorotiazida por un diurético antialdosterónico
C) Agregar doxazosina al tratamiento
D) Agregar espironolactona y solicitar exámenes para descartar una hipertensión secundaria
E) Reemplazar el amlodipino por diltiazem

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Agregar espironolactona y solicitar exámenes para descartar una hipertensión secundaria** (opción **D**). Tratamiento: corticoides orales (detener avance) + cirugía vascular (desobstruir arterias) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 171 · 1.01.1.016 · Hipertensión arterial secu

Un paciente de 37 años acude a chequeo médico en el que destaca presión arterial de 170/110 mmHg. No 8ene obesidad ni antecedentes familiares de hipertensión. Se solicita un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, confirmándose el diagnós8co de hipertensión arterial, por lo que se inicia losartán 50 mg al día y amlodipino 5 mg al día. Se controla un mes después y el paciente refiere que ha mantenido presiones arteriales cercanas a 160/100 mmHg. Los exámenes de laboratorio muestran crea8ninemia: 0,9 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, sodio plasmá8co: 140 mEq/L y potasio plasmá8co: 4,4 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de los fármacos
B) Agregar un diuré2co al tratamiento
C) Solicitar ecogra:a Doppler renal
D) Solicitar niveles plasmá2cos de aldosterona
E) Solicitar metanefrinas y catecolaminas en orina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una HTA secundaria (severa, refractaria, sin antecedentes familiares ni obesidad). Por tanto, se debe estudiar con más de un examen: ecografía Doppler renal, aldosterona (idealmente como índice aldosterona / acGvidad de renina plasmática) e incluso metanefrinas urinarias. Sin embargo, obligan a elegir solo una, por lo que se debe identificar la causa más probable. Por la edad el hiperaldosteronismo primario (HAP) es más probable que la HTA renovascular. Además, aunque la hipokalemia sugiere un HAP, la mayoría de los HAP son normocalémicos, más aún si está usando IECAs o ARA2, que Genden a la hiperkalemia. No Gene la clínica paroxística del feocromocitoma, además de ser una patología muy infrecuente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 136 · 1.01.1.016 · Hipertensión arterial secu

Un paciente de 38 años, diagnosticado de hipertensión arterial, está en tratamiento con enalapril 20 mg c/12 horas, hidroclorotiazida 25 mg/d y amlodipino 10 mg/día. Se realiza control con monitoreo de 24 horas de presión arterial que muestra presiones arteriales diurnas promedio de 152/100 mmHg, con sobrecarga tensional de 60% sistólica y 43% diastólica y presiones arteriales nocturnas de 140/92 mmHg, con sobrecarga tensional de 25% sistólica y 27% diastólica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de hidroclorotiazida
B) Aumentar la dosis de enalapril
C) Iniciar inhibidor del receptor de aldosterona y descartar hipertensión secundaria
D) Reemplazar el enalapril por losartán
E) Reemplazar la hidroclorotiazida por un inhibidor del receptor de aldosterona

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una HTA refractaria, ya que está tratada con 3 fármacos, incluyendo un diurético, en dosis altas (la HCTZ se puede aumentar a 50 mg, pero sigue siendo una HTA refractaria este caso). Por tanto, se debe agregar espironolactona y buscar una causa secundaria. Además, como dato, la sobrecarga tensional muestra el tiempo que están las presiones sobre el valor normal (se llama HTA enmascarada o "hipertensión del delantal blanco INVERSO" cuando las presiones arteriales son normales en la consulta y el promedio de PA en el monitoreo de 24 horas es normal, pero la sobrecarga tensional es elevada: mayor a 40% en adultos; en niños el corte es 25%).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 158 · 1.01.5.006 · Resucitación cardiorespira

Un paciente de 67 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, fumador activo, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo e intenso, de 2 horas de evolución, irradiado al hombro derecho y asociado a disnea. Mientras estaba en la sala de reanimación presenta pérdida de conciencia y usted constata que no se mueve, no respira y no tiene pulso. Además de pedir ayuda y activar el código de paro, ¿cuál es la conducta inmediata?

A) Instalar el monitor cardíaco en modo paletas
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Solicitar electrocardiograma
D) Realizar compresiones torácicas
E) Administrar adrenalina endovenosa en bolo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar compresiones torácicas** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 163 · 1.01.4.002 · Angiotac de tórax y aorta

Paciente con dolor retroesternal irradiado a dorso que cedió, presión elevada, sudoración y pulsos distales débiles. ¿Cuál es el examen de elección?

A) AngioTAC de tórax y abdomen
B) Ecocardiografía transtorácica urgente
C) Coronariografía urgente
D) Radiografía de tórax anteroposterior
E) Resonancia magnética cardíaca

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (AngioTAC de tórax y abdomen). AngioTAC de tórax y abdomen. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 43 1.01.2.001 · Angina inestable

Síndrome adrenérgico por cocaína. Fármaco contraindicado.

A) Atenolol
B) Captopril
C) Nitroglicerina
D) Diltiazem
E) Amoxicilina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La opción correcta es la **A** (Atenolol). En este escenario clínico, atenolol se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 180 1.01.4.007 · Electrocardiograma

Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico se encuentra orientado, en Glasgow 15, con frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas
B) Ecocardiograma
C) TAC de cerebro
D) Resonancia magnética de cerebro
E) Electrocardiograma

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Evaluación del Síncope Cardiogénico: En un paciente con sospecha de síncope cardiogénico debido a una bradiarritmia, el electrocardiograma (ECG) es el examen inicial esencial. El ECG puede identificar bloqueos auriculoventriculares, enfermedad del nodo sinusal y alteraciones hidroelectrolíticas como la hiperpotasemia, que se asocian con este tipo de arritmias.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 62 1.01.4.007 · Electrocardiograma

Síncope en un adulto mayor que iba caminando, pierde conciencia subitamente, se golpea la cabeza y queda con herida en cuero cabelludo, se recupera bien, FC 60. El estudio inicial del cuadro (ojo no decía etiológico):

A) Estudio inicial con ecg (sería esta si preguntaran la causa) b. TAC cerebral (sería esta si preguntan por el estudio del TEC -por ser adulto mayor se debe estudiar-)
B) Insuficiencia cardíaca
C) Fibrilación auricular
D) Infarto agudo al miocardio
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Estudio inicial con ecg (sería esta si preguntaran la causa) b. TAC cerebral (sería esta si preguntan por el estudio del TEC -por ser adulto mayor se debe estudiar-)). El electrocardiograma es la herramienta diagnóstica más importante en el síndrome coronario agudo (SCA). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 88 1.01.2.005 · Insuficiencia cardíaca agu

(88) Paciente de 82 años con historia de 2 semanas de disnea progresiva FC 92 lpm PA 200/100 SatO2 90%. Al examen físico ingurgitación yugular, ritmo regular en tres tiempos por R3 al examen pulmonar créditos bibasales. ECG: ritmo sinusal con signos de sobrecarga del VI. Diagnóstico más probable:

A) SCA
B) Disección aórtica
C) NAC
D) IC aguda
E) TEP f. Dolor torácico súbito, transfixiante, HTA y soplo diastólico.

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **IC aguda** (opción **D**). Esta clase aborda la interpretación del equilibrio ácido-base mediante gasometría arterial o venosa. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 152 1.01.2.005 · Insuficiencia cardíaca agu

Paciente que tenía una insuficiencia cardiaca aguda, con tercer ruido.

A) Cor pulmonale del EPOC
B) Insuficiencia cardíaca descompensada
C) Fibrilación auricular
D) Infarto agudo al miocardio
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Insuficiencia cardíaca descompensada). Esta clase aborda la interpretación del equilibrio ácido-base mediante gasometría arterial o venosa. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 155 1.01.4.001 · Coronariografía

Test de esfuerzo alterado cual era el siguiente paso?: a. Coronariografía

A) Insuficiencia cardíaca
B) Fibrilación auricular
C) Infarto agudo al miocardio
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Pericarditis aguda

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Insuficiencia cardíaca). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Fibrilación auricular, Infarto agudo al miocardio) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 88 1.01.1.021 · Paciente con soplo

Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela, con infecciones respiratorias recurrentes. Signos vitales normales, auscultación pulmonar normal. A la auscultación cardiaca se detecta un soplo continuo de intensidad III/VI en la región paraesternal e infraclavicular izquierda. Talla -1 DE para su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Comunicación interventricular
C) Comunicación interauricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Soplo funcional

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ductus Arterioso Persistente: El soplo continuo (maquinaria) es característico del ductus arterioso persistente. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 4 1.01.5.004 · Desfibrilación

Un paciente de 64 años, con antecedente de diabetes mellitus 8po 2 e hipertensión arterial mal controlados, consulta en el servicio de urgencia por dolor torácico opresivo EVA 9/10, asociado a disnea y malestar general. Durante su atención presenta un electrocardiograma que muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cardioversión eléctrica
B) Desfibrilación eléctrica
C) Amiodarona endovenosa
D) Maniobras de reanimación cardiopulmonar
E) Coronariogra:a urgente

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El ECG corresponde a un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST (cara inferior), que evoluciona a fibrilación ventricular, lo que consGtuye un paro cardíaco presenciado en ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso). Por ser un paro presenciado, la conducta inmediata es la desfibrilación eléctrica. Las maniobras de RCP se inician de forma simultánea, pero no reemplazan la desfibrilación precoz. La cardioversión se realiza en las taquiarritmias con hemodinamia inestable, pero con pulso.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 150 1.01.3.003 · Manejo del paciente en tra

Un paciente de 62 años, con antecedente de prótesis mecánica de válvula mitral e insuficiencia renal crónica, con un clearence de crea8nina es8mado de 20 ml/min, presenta un cuadro de palpitaciones. Se realiza electrocardiograma que muestra una taquiarritmia irregular con QRS angosto y ausencia de onda P. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para su manejo?

A) Apixabán
B) Enoxaparina
C) Dabigatrán
D) Acenocumarol
E) Rivaroxabán

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los cumarínicos (warfarina y acenocumarol) son los anticoagulantes de elección en los pacientes con prótesis valvular mecánica (están contraindicados los nuevos anticoagulantes orales), en los pacientes con IRC severa (sí se puede usar el apixabán en la IRC; no se recomiendan heparinas de bajo peso) y en el síndrome an<fosfolípidos.

INFECTOLOGÍA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 02

110 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

32 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.1.004	Brucelosis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.006	Celulitis bacteriana	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 02 · 5.1 (Pág. 55)
1.04.1.009	Diarrea asociada a antibióticos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 06 · 3.1 (Pág. 37)
1.04.1.010	Enfermedades de transmisión sexual	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	14 Q	Tomo 02 · 3.5 (Pág. 35)
1.04.1.011	Enfermedades eruptivas no complicadas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 02 · 5.3 (Pág. 59)
1.04.1.012	Fiebre tifoídea y paratifoídea	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 02 · 4.5 (Pág. 48)
1.04.1.013	Hidatidosis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)
1.04.1.014	Infección por virus de inmunodeficiencia humana	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	8 Q	Tomo 02 · 3.1 (Pág. 27)
1.04.1.016	Influenza	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 06 · 4.1 (Pág. 52)
1.04.1.018	Malaria	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · 4.3 (Pág. 44)
1.04.1.019	Micosis invasora	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29)
1.04.1.021	Osteomielitis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 06 · 5.4 (Pág. 77)
1.04.1.022	Parasitosis intestinales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 06 · 5.5 (Pág. 79)
1.04.1.023	Sífilis secundaria, terciaria y congénita	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 02 · 3.4 (Pág. 33)
1.04.1.025	Síndrome mononucleósico	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 02 · 5.2 (Pág. 57)
1.04.1.026	Toxicoinfección alimentaria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 02 · 2.4 (Pág. 22)
1.04.1.027	Triquinosis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · 4.4 (Pág. 46)
1.04.1.028	Tuberculosis extrapulmonar	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	8 Q	Tomo 02 · 3.3 (Pág. 31)
1.04.2.002	Encefalitis aguda	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · 1.3 (Pág. 9)
1.04.2.003	Endocarditis bateriana	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)
1.04.2.005	Infección invasiva de partes blandas:	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 02 · 1.4 (Pág. 11)
1.04.2.006	Meningitis aguda	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 02 · 1.2 (Pág. 7)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.04.2.008	Síndrome pulmonar por Hanta Virus	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · 4.1 (Pág. 40)
1.04.3.005	Prevención de infecciones hospitalarias	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · 2.3 (Pág. 20)
1.04.3.006	Prevención de infecciones oportunistas en VIH (+)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · 3.2 (Pág. 29)
1.04.3.009	Profilaxis de tuberculosis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 02 · 2.1 (Pág. 16)
1.04.3.011	Uso y abuso de antibióticos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)
1.04.4.007	Cultivo de expectoración	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)
1.04.4.008	Gram	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)
1.04.4.015	Reacción de polimerasa en cadena	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)
1.04.4.016	Serología de enfermedades infecciosas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 02 · 4.2 (Pág. 42)
1.04.4.017	Urocultivo y antibiograma	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 02 · Infectología (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 37 1.04.2.006 · Meningitis aguda

Mujer de 23 años, con cuadro de 24 horas de evolución de compromiso del estado general, fiebre y soñolencia progresiva. Al examen físico destaca con temperatura de 38,5ºC, petequias y equimosis en extremidades, rigidez de nuca sin focalización neurológica. El diagnóstico más probable es:

A) Meningitis tuberculosa
B) Meningitis meningococica
C) Meningitis neumocócica
D) Meningitis por listeria
E) Meningitis herpética

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Meningitis meningococica** (opción **B**). Tiene un cuadro sugerente de MBA. Las petequias y equimosis son de meningococcemia.. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 81 1.04.2.006 · Meningitis aguda

Un paciente de 65 años, consulta por fiebre y cefalea de 3 días de evolución, a lo que luego se agrega desorientación. Al examen físico se aprecia confuso, con temperatura 38,5 grados Celsius, FC: 95x' y PA: 110/70 mmHg. En su examen neurológico se aprecia rigidez de nuca, por lo que realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalo-rraquídeo con 610 células por mm3, con 90% de polimorfonucleares, glucosa: 26 mg/dl y proteínas 123 mg/dl. Además, la tinción de Gram muestra visualización de diplococos gramnegativos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Ceftriaxona endovenosa
B) Cloxacilina endovenosa
C) Vancomicina endovenosa
D) Imipenem endovenoso
E) Ciprofloxacino oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ceftriaxona endovenosa** (opción **A**). Es una meningitis por meningococo, que se trata con ceftriaxona o penicilina endovenosas.. Diagnóstico meningitis: TAC primero (descartar HTE), luego punción lumbar. Ante la duda, tratar como bacteriana. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 130 1.04.2.006 · Meningitis aguda

Una paciente de 25 años presenta un cuadro de cefalea holocránea y fiebre alta. Al examen físico presenta rigidez de nuca y signo de Brudzinsky, con petequias en extremidades inferiores, asociadas a algunas equimosis. El agente causal más probable es:

A) Neisseria meningitidis
B) Streptococcus pneumoniae
C) Haemophilus influenzae
D) Listeria monocytogenes
E) Viris herpes simplex

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Neisseria meningitidis). Cuadro clásico de meningococcemia. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 61 1.04.2.006 · Meningitis aguda

Un paciente consulta por 5 días de cefalea holocránea intensa, asociada a fiebre hasta 38 grados. En su examen físico se aprecia rigidez de nuca y signo de Brudzinsky esbozados, por lo que se realiza punción lumbar, que da salida a un líquido con 60 células por mm3, 86% mononucleares, glucorraquia: 0,67 y proteínas de 66 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Meningitis bacterial
B) Encefalitis herpética
C) Meningitis viral
D) Tuberculosis meníngea
E) Infección por Listeria monocytogenes

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Meningitis viral** (opción **C**). Es una meningoencefalitis viral clásica. No tenía ningún criterio de sospecha de herpes.. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 102 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Paciente institucionalizado con Alzheimer, postrado, con sonda vesical cambiada hace 2 semanas, urocultivo con E. coli multisensible asintomática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tratar con ciprofloxacino oral por 7 días
B) Cambiar la sonda y tratar 3 días
C) Mantener observación sin tratar
D) Tratar con nitrofurantoína oral por 5 días
E) Hospitalizar para antibiótico endovenoso

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener observación sin tratar** (opción **C**). Mantener observación sin tratar. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 33 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Adulto mayor de 78 años con sonda Foley permanente. Urocultivo de rutina: E. coli >100.000 UFC/mL. El paciente está asintomático y afebril. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) No tratar; bacteriuria asintomática en portador de sonda no requiere antibióticos
B) Iniciar nitrofurantoína por 7 días
C) Iniciar ciprofloxacino por 7 días
D) Cambiar sonda y tratar con cefazolina
E) Repetir urocultivo en 48 horas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Bacteriuria asintomática en portador de catéter urinario: no se trata con antibióticos (guías IDSA). El tratamiento aumenta resistencia sin beneficio clínico, salvo en embarazadas o previo a procedimiento urológico.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 114 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Un paciente de 85 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, que se cambia cada 30 días. Al momento de cambiarle la sonda, se observan orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible solo a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. El paciente está asintomático, afebril, sin mayor confusión de la habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar nitrofurantoína v.o.
B) Iniciar gentamicina i.m.
C) Iniciar imipenem e.v.
D) Observar evolución, sin necesidad de retirar la sonda
E) Cambiar la sonda, sin necesidad de antibióticos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una bacteriuria asintomática, que se observa, incluso en el adulto mayor o en el paciente sondeado (solo se trata en la embarazada). Si es resistente a las cefalosporinas, habría sido BLEE y, por tanto, si tuviese síntomas, el carbapenémico sería la respuesta.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 69 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Mujer 70 años con orina de mal olor, sin ningún síntoma urinario, sedimento leucocitos 2-3/campo, bacterias abundantes . Conducta: a. Se observa y controla si parte con síntomas

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Staphylococcus aureus** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 124 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Un paciente de 87 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, que se cambia cada un mes, presenta orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli

A) Iniciar nitrofurantoína v.o.
B) Iniciar gentamicina i.m.
C) Iniciar imipenem e.v.
D) Observar evolución, sin necesidad de retirar la sonda
E) Solicitar hemograma, VHS y PCR y decidir conducta según hallazgos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una bacteriura asintomática en el paciente sondeado. Al igual que la mayoría de las bacteriuras asintomáticas, no requiere tratamiento.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 38 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Una paciente de 33 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de dolor lumbar y fiebre desde hace un día, asociado a disuria y orinas de mal olor. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con temperatura de 38ºC y en el resto del examen solo destaca puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina y urocultivo, con lo que se confirma pielonefritis aguda por lo que inicia tratamiento ambulatorio con ciprofloxacino. Dos días después acude a control persistiendo sintomática. Su resultado del urocultivo muestra presencia de echericha coli sensible a nitrofurantoina, carbapenémicos, ampicilina/sulbactam y amikacina, y resistente a cefalosporinas, gentamicina y ciprofloxacino. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el de elección para el manejo en este caso?

A) Amikacina
B) Nitrofurantoina
C) Ertapenem
D) Ampicilina
E) Moxifloxacino

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una E. coli BLEE (resistente a cefalosporinas), aunque sea sensible a la amyka, por ser resistente a la genta, se prefiere el carbapenémico. La verdad que por ser BLEE ya se prefiere el ertapenem u otro carbapenémico. Recordar eso sí, que el ertapenem no sirve contra pseudomona: en ese caso se usaría imipenem o carbapenem. El ertapenem tiene además el beneficios de solo necesitar una dosis al día, por lo que incluso en algunos pacientes se los maneja de manera ambulatoria (llegan a inyectarse una vez al día).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 2 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Las preguntas aparecieron, por primera vez, en dos columnas (ahorraron hojas, a expensas de tener imágenes muy pequeñas).

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hay dos cosas importantes: 1. toda infección intrahospitalaria debe estudiarse y mientras tanto recibir cobertura para microorganismos resistentes (en este caso la vancomicina cubre S. aureus meticilino resistente, Enterococo resistente a ampicilina y Neumococo resistente a penicilina, aunque este último no produce infecciones intrahospitalarias. 2. Una vez que se identifica el microorganismo, se cubre de la manera más simple posible. 3. La cloxacilina es más potente antibiótico que la vancomicina en las bacterias sensibles. 4. El cefotaximo no cubría bien pseudomona, así que al inicio habría sido mejor dejar vancomicina + cefoperazona o cefepime.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 120 1.04.3.011 · Uso y abuso de antibiótico

Un paciente incia tratamiento antituberculoso con 4 fármacos, por una tuberculosis pulmonar. Al séptimo día de tratamiento presenta vómitos y dolor abdominal luego de recibir los fármacos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar omeprazol al tratamiento
B) Retirar uno de los 4 fármacos
C) Suspender el tratamiento y solicitar pruebas hepáticas
D) Derivar para tratamiento secundario
E) Mantener el tratamiento

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien, la información es escasa, al sospechar una reacción adversa a medicamentos, se deben suspender y confirmar la afectación, que en el caso de los fármacos antiTBC, es la hepatitis la complicación más frecuente

---

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 62 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Un paciente de 37 años consulta por fiebre y malestar general de dos días de evolución, asociado a odinofagia. Al examen físico, tiene FC: 96x', PA: 110/70 mmHg, T°: 38,0°C. Se observan úlceras orales, se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se observa un exantema maculopapular eritematoso con distribución predominante en el tronco. Su examen cardiopulmonar es normal. Al examen neurológico, presenta algún grado de confusión y se palpa rigidez de nuca esbozada. Presenta serología negativa para VIH y para virus de Epstein Barr y se realiza una punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de predominio mononuclear y glucorraquia de 55 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Primoinfección por VIH
B) Meningoencefalitis por citomegalovirus
C) Meningitis bacteriana aguda
D) Neurosífilis
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome retroviral agudo o primoinfección por VIH: El síndrome retroviral agudo es la primera etapa de la infección por VIH. Se manifiesta clínicamente como un síndrome mononucleósico, que suele incluir fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos y fatiga. A menudo se acompaña de un exantema rosado. En algunos casos, el síndrome retroviral agudo puede complicarse con meningitis aséptica, de tipo viral, con líquido cefalorraquídeo de predominio de células mononucleares y glucorraquia superior a 40 mg/dL. Durante el período de ventana, que es el tiempo que transcurre entre la infección por VIH y la aparición de anticuerpos detectables en la sangre, la serología para VIH puede ser negativa. Por lo tanto, el examen de elección para diagnosticar el síndrome retroviral agudo es la PCR para VIH o la detección de antígenos del VIH, ya que estas pruebas detectan directamente el virus. En cambio, en la infección crónica por VIH, el diagnóstico se realiza mediante serología (ELISA) y se confirma con Western blot, ya que en esta etapa los anticuerpos contra el VIH ya son detectables en la sangre.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 56 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Una paciente de 33 años, VIH positivo, cursa un embarazo bien controlado, con tratamiento antirretroviral y cargas virales indetectables. El recién nacido nace a las 38 semanas, por parto vaginal, sin complicaciones. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento antirretroviral de elección para el recién nacido?

A) Zidovudina (AZT)
B) Lamivudina (3TC)
C) Nevirapina (NVP)
D) Lopinavir (LPV)
E) Abacavir (ABC)

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo: Para evitar la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) al recién nacido, la madre debe recibir terapia antirretroviral durante todo el embarazo (medida más importante). El objetivo es lograr cargas virales indetectables, lo que permite un parto vaginal. Si no se logran cargas virales indetectables, se debe realizar una cesárea. El recién nacido debe recibir terapia antirretroviral por varias semanas después del nacimiento. Además, la lactancia materna está absolutamente contraindicada. Para el seguimiento del recién nacido se utiliza la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar el VIH, ya que las pruebas de ELISA y Western blot pueden dar resultados falsos positivos debido a la presencia de anticuerpos maternos. El esquema de terapia antirretroviral para el recién nacido varía según el riesgo de infección. En recién nacidos de bajo riesgo (por ejemplo, nacidos a término de madres con cargas virales indetectables durante el embarazo) se utiliza zidovudina como monoterapia. En recién nacidos de alto riesgo (por ejemplo, aquellos cuyas madres tenían cargas virales elevadas durante el embarazo) se utiliza una terapia triple que combina zidovudina, lamivudina y nevirapina.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 99 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Emb de 32 semanas con Vih (+) sin tto, cual es la mejor conducta para prevenir transmision vertical:

A) Iniciar TARV
B) interrumpir embarazo
C) TARV intraparto
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar TARV** (opción **A**). Diagnóstico: PCR (de elección) o inmunofluorescencia directa; beta-D-glucano es inespecífico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 86 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Pregunta 86 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta ¿Cuál es la estrategia más efectiva para evitar la transmisión vertical del VIH, desde la madre embarazada al hijo?

A) Tratamiento a la madre durante el embarazo y el parto
B) Cesárea electiva
C) Contraindicación de la lactancia materna
D) Tratamiento a la madre durante la lactancia
E) Profilaxis al recién nacido

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La triterapia durante el embarazo es la medida más importante. Además, se hace cesárea, se prohíbe la lactancia materna y se le da profilaxis al recién nacido, pero todas esas medidas inciden muy poco, en comparación a la TAR durante el embarazo.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 57 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Un paciente de 21 años, con antecedente de dermatitis atópica y onicomicosis en manos y pies, es diagnosticado por varicela necrohemorrágica la cual es manejada con aciclovir. ¿Cuál de las siguientes patologías de base es más probable que tenga este paciente?

A) Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina A
B) Inmunodeficiencia por alteración en la fagocitosis
C) Inmunodeficiencia por déficit de inmunoglobulina G
D) Inmunodeficiencia por déficit de complemento
E) Inmunodeficiencia combinada adquirida

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene VIH, que es una ID adquirida, de tipo combinada. El déficit de IgA da diarreas y bronquitis. El déficit de IgG da infecciones por Neumococo, meningococo y haemophilus. El déficir de C` da infecciones por meningococo. El déficit de fagocitosis da infecciones por bacterias y aspergillus.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 115 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Un paciente de 40 años, con antecedente de infección crónica por VIH, diagnosticado hace 4 años, consulta por diarrea de 3 meses, de tipo acuoso, sin fiebre, asociado a dolor abdominal y baja de peso. Al examen físico está afebril, tiene algorra y presenta abdomen blando, depresible, levemente doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Salmonella typhi
B) Clostridium difficile
C) Criptococcus sp.
D) Microsporidium
E) Toxoplasma gondii

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La diarrea crónica en el paciente VIH es primeramente por Criptosporidium sp. Luego por Isospora Belli y discutiblemente por Microsporidium sp.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 60 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Un paciente de 36 años presenta desde hace un mes tos irritativa, que se ha vuelto productiva, con expectoración mucosa y últimamente mucopurulenta, asociada a fiebre y malesar general. Al examen está enflaquecido, satura 93% a FiO2 ambiental, tiene FC: 80x', PA: 110/60 mmHg y FR: 21 rpm. A su examen pulmonar, se auscultan crépitos difusos en ambos campos pulmonares, más algunas sibilancias. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con patrón alveolointersticial bilateral difuso). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Mycobacterium tuberculosis
C) Staphilococcus aureus
D) Mycoplasma pneumoniae
E) Pneumocystis jiroveci

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Pneumocystis jiroveci). La clínica y la radiografía orientaban mucho a un paciente VIH con infección por PJ.. La neumonía por Pneumocystis jirovecii es la infección oportunista más frecuente como enfermedad de debut en pacientes con VIH. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 25 1.04.1.014 · Infección por virus de inm

Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa con expectoración escasa, que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos en los últimos días. Al examen físico, se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones bilaterales difusas, con estertores y algunas sibilancias en ambos campos pulmonares. Se solicita radiografía de tórax que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia.org): El diagnóstico más probable es:

A) Fibrosis pulmonar
B) Asma bronquial
C) Neumonitis viral
D) Neumonía por Mycoplasma pneumoniae
E) Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta difícil, pero parece un cuadro de neumonía por Pneumocystis, en contexto de un paciente joven con VIH, que está debutando (orienta la baja de peso y la radiografía con infiltrado difuso). El mycoplasma es una opción aceptable, pero suele durar 2a4semanas.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 128 1.04.1.009 · Diarrea asociada a antibió

Una paciente está en tratamiento con ciprofloxacino por una infección urinaria. Al séptimo día inicia diarrea acuosa, abundante, asociada a dolor abdominal. Al axamen físico se constata dolor a la palpación abdominal, sin irritación peritoneal, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Los leucocitos fecales resultan positivos. ¿Cuál es el agente etiológico?

A) Escherichia coli
B) Clostridium difficile
C) Shiguella flexneri
D) Rotavirus
E) Campilobacter jejuni

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Clostridium difficile** (opción **B**). Diarrea post-ATB es por C. difficile en el 30% de los casos.. DM1 siempre requiere insulina desde el diagnóstico con esquema basal-bolo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 59 1.04.1.009 · Diarrea asociada a antibió

Paciente de 70 años, diabético en tratamiento farmacológico y hospitalizado por neumonía desde hace 5 días, comienza desde ayer con cuadro de deposiciones diarreicas acuosas asociado a desorientación temporoespacial. Al examen físico destaca abdomen doloroso a palpación profunda, con ruidos hidroaéreos aumentados y ausencia de irritación peritoneal. Se solicita coprocultivo que se informa negativo y leucocitos fecales positivos. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Hidratación por vía oral abundante
B) Metronidazol oral
C) Ciprofloxacino oral
D) Clindamicina ev
E) Probióticos orales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diarrea por ATB, probablemente por C. difficile. Se trata con MTZ. Eso sí, primero se debería confirmar el diagnóstico con la PCR para Clostridium difficile.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 64 1.04.1.009 · Diarrea asociada a antibió

Una mujer de 28 años, puérpera de 2 meses, con 3 semanas de diarreas con presencia de sangre y dolor abdominal difuso leve. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con abdomen blando, sensible a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal, con meteorismo. El diagnóstico más probable es:

A) Diarrea debida a Clostridium difficile
B) Colitis ulcerativa
C) Enfermedad de Cröhn
D) Colitis inespecífica
E) Shigellosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Seguro recibió antibióticos en el puerperio, por lo que se sospecha la diarrea por C. difficile. Las otras opciones no tienen relación con el antecedente de puerperio.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 126 1.04.1.009 · Diarrea asociada a antibió

Paciente con antecedente de diverticulitis hace 10-15 días tratada con ATB oral (ciprofloxacino + metronidazol), consulta SU por diarrea múltiples episodios, con pujo y tenesmo, fiebre? dolor y sangrado: a. Diarrea por clostridium (sg yo era un cuadro clásico de diarrea por CD 2° a uso de ATB) b. Reagudización de diverticulitis por rectitis c. Absceso diverticular no puede ser CU? - el pujo y tenesmo no orientaría a CU? Vi una similar en una reconstrucción y era CU x eso,, era muy vieja para ser CU

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Staphylococcus aureus). La insulina es el tratamiento de elección en la diabetes tipo 1 y tiene indicaciones precisas en la diabetes tipo 2. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 113 1.04.1.009 · Diarrea asociada a antibió

Una paciente de 43 años es diagnosticada de bronquitis, iniciándose tratamiento con amoxicilina oral por 14 días, con buena respuesta. Al décimo día de tratamiento antibiótico evoluciona con dolor abdominal y diarrea, que en oportunidades es sanguinolenta. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar sales de rehidratación oral
B) Solicitar parasitológico seriado de deposiciones
C) Agregar ciprofloxacino al tratamiento
D) Solicitar colonoscopía
E) Suspender el tratamiento antibiótico y solicitar toxinas de Clostridium difficile en deposiciones

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Lo más importante es confirmar el diagnóstico de C. difficile. Sin embargo, las toxinas han sido desplazadas por la PCR (aunque tiene más falsos positivos) y en general no es necesario suspender los antibióticos (en este caso sí se debían suspender, porque no estaban indicados, ya que las bronquitis no se tratan con ATB).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 132 1.04.1.009 · Diarrea asociada a antibió

Un paciente es hospitalizado durante 10 días por causa de una neumonía neumocócica adquirida en la comunidad. Algunos días después de haber sido dado de alta, presenta diarrea líquida abundante, con 5 a 6 evacuaciones al día, asociada a dolor abdominal, malestar general y febrículas hasta 37.3°C. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Colonoscopía
B) Parasitológico ampliado de deposiciones
C) Coprocultivo
D) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para Clostridium difficile
E) Ecografía abdominal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diarrea por Clostridioides (Clostridium) Difficile: Tras recibir antibióticos, se debe descartar diarrea por Clostridioides difficile mediante PCR, que ha reemplazado las pruebas de toxinas A y B en heces.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 132 1.04.1.009 · Diarrea asociada a antibió

Una paciente de 43 años está en tratamiento antibiótico, hace 2 semanas por una neumonía nosocomial. Evoluciona con diarrea acuosa, asociada a dolor abdominal intenso, tipo cólico y fiebre hasta 38,3°C. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio de esta paciente?

A) Leucocitos fecales
B) Colonoscopía
C) Parasitológico de deposiciones
D) Toxinas A y B de Clostridium difficile en deposiciones
E) Coprocultivo Respuesta: La diarrea por C. difficile se estudia preferentemente con PCR para C. difficile, en deposiciones. Si no está disponible, pues también sirven las toxinas A y B. La respuesta correcta es: Toxinas A y B de Clostridium difficile en deposiciones ¿Te gustaría que te ayude a buscar material de estudio adicional para alguno de estos temas médicos?

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La diarrea por C. difficile se estudia preferentemente con PCR para C. difficile, en deposiciones. Si no está disponible, pues también sirven las toxinas A y B.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 116 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Un paciente de 54 años, con antecedente de artri8s reumatoide severa, inicia tratamiento con cor8coides sistémicos y terapia biológica, por lo que se realiza estudio de tuberculosis latente con PPD, el que resulta posi8vo, indicándose tratamiento con isoniacida por 6 meses, permaneciendo asintomá8co. Un año después consulta por lumbago muy intenso, EVA 8/10, de 10 días de evolución, que ha empeorado en los úl8mos días y no ha respondido a analgésicos. En el examen Fsico el dolor limita los movimientos de flexoextensión. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 30% con hemoglobina: 10 g/dL, glóbulos blancos: 12.000/mm³, plaquetas: 480.000/mm³ y VHS: 80 mm/h. La radiograFa de tórax es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para evaluar a este paciente?

A) Radiogra:a de columna lumbar
B) Resonancia magné2ca nuclear lumbar
C) Cin2gra:a ósea
D) ELISPOT
E) PET-scan

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una tuberculosis vertebral, conocida como mal de Pox. Es una osteomieliGs, por lo que el examen de elección es la RMN. La cintigrafía es una opción, pero menos específica, por lo que ha sido desplazada por la RMN. La prueba ELISPOT es un IGRA (Interferon-Gamma Release Assay), que se usa en el diagnóstico de la TBC latente, al igual que el PPD y otros IGRAs.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 112 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Un paciente de 45 años, sin antecedentes, presenta cuadro de 3 semanas devolución de cefalea y sensación febril que durante los últimos días se ha hecho más intensa, asociado a dolor cervical. Al examen físico destaca leve rigidez de nuca y parálisis del IV par craneano derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Meningitis tuberculosa
B) Meningoencefalitis por enterovirus
C) Meningoencefalitis herpética
D) Meningitis bacteriana
E) Meningitis por hongos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Meningitis tuberculosa** (opción **A**). Por clínica de parálisis del IV par y por lo subagudo del cuadro: 3 semanas. La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis y se presenta con tos, expectoración (mucosa, purulenta o hemoptoica), fiebre y baja de peso por al menos 2 semanas. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 71 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Un paciente de 35 años, sin antecedentes, con cuadro de una semana de compromiso del estado general y sensación febril, que durante los últimos días se agrega cefalea y diplopía. Al examen físico destaca reflejo fotomotor conservado, parálisis del sexto par derecho y rigidez de nuca esbozada. Se solicita punción lumbar que muestra células aumentadas de predominio mononuclear, glucosa disminuida y proteínas altas, gram no visualiza gérmenes. El agente etiológico más probable en este caso es:

A) Mycobacterium tuberculosis
B) Neumococo
C) Enterovirus
D) Herpes virus
E) Criptococosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Mycobacterium tuberculosis). Es una meningitis TBC tanto por el LCR, como por la clínica, con compromiso de los pares craneales.. La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis y se presenta con tos, expectoración (mucosa, purulenta o hemoptoica), fiebre y baja de peso por al menos 2 semanas. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 21 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Paciente de 35 años VIH (+) con tos productiva de 3 semanas, baja de peso y sudoración nocturna. Baciloscopia de esputo positiva. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Isoniazida + Rifampicina + Pirazinamida + Etambutol por 2 meses, luego Isoniazida + Rifampicina por 4 meses
B) Claritromicina + Etambutol por 6 meses
C) Moxifloxacino + Rifampicina por 9 meses
D) Isoniazida en monoterapia por 9 meses
E) Cotrimoxazol forte por 6 meses

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

TBC pulmonar activa: esquema HRZE 2 meses + HR 4 meses (total 6 meses), independiente del status VIH. En VIH se inicia TARV dentro de 2-8 semanas del inicio del tratamiento anti-TBC.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 105 · 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Una mujer de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de tos con expectoración mucopurulenta, asociada a sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre intermitente. Al examen físico tiene T°: 37,1°C, PA: 130/82 mmHg, FC: 96x', saturación O2: 96% y a la auscultación pulmonar se oyen estertores y crépitos bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra más abajo (fuente: Radiopaedia). Se solicitan baciloscopías de expectoración, que resultan negativas y prueba de quantiferón-TB, que también resulta negativa. Su marido está en tratamiento antituberculoso por tuberculosis pulmonar activa. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de esta paciente?

A) Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis
B) Solicitar prueba de IGRA (ensayo de liberación de interferón gamma)
C) Realizar lavado bronquioalveolar
D) Solicitar TAC de tórax
E) Iniciar tratamiento antituberculoso

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de la Tuberculosis: El paciente presenta un cuadro clínico y radiográfico compatible con una infección tuberculosa. Si bien las baciloscopías resultaron negativas, los antecedentes epidemiológicos (el marido tiene tuberculosis activa), sumados a la clínica y la radiografía, son suficientes para iniciar el tratamiento antituberculoso de inmediato. Se puede solicitar una PCR para Mycobacterium tuberculosis para confirmar el diagnóstico, pero no es necesario esperar los resultados para comenzar el tratamiento, ya que la probabilidad es muy alta y se trata de una patología grave. El quantiferón y los IGRAs sirven para el diagnóstico de tuberculosis latente y no para la sospecha de tuberculosis activa.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 91 · 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Paciente con VIH sin TARV, fiebre, baja de peso, hemoptisis, baciloscopías negativas y cultivo MGIT positivo. ¿Cuál es la conducta?

A) Iniciar TARV e investigar otras infecciones oportunistas
B) Solicitar broncoscopía y biopsia transbronquial
C) Iniciar profilaxis con isoniazida y observar
D) Repetir baciloscopías y esperar resultado de cultivo
E) Iniciar tratamiento estándar para tuberculosis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar tratamiento estándar para tuberculosis** (opción **E**). Iniciar tratamiento estándar para tuberculosis. Baciloscopías de expectoración: examen de elección; pedir 3-4; sensibilidad 80%; muestra válida si > 50 neutrófilos/campo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 8 · 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Un paciente de 42 años consulta por tos y disnea de 2 semanas de evolución, asociada a expectoración mucopurulenta y, en ocasiones, hemoptoica. Además, ha presentado fiebre ocasional, hasta 38,2°C. Al examen físico presenta estertores bilaterales en ambos campos pulmonares. Se solicitaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas. Además, se solicita otros exámenes, que muestran quantiferón para tuberculosis (+) y PCR para Mycobacterium tuberculosis (+). Su radiografía de tórax se muestra más abajo. Foto 1 (https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082004000400006) (La imagen ha sido ennegrecida, para que se parezca a las imágenes reales del Eunacom impreso). La conducta más adecuada es:

A) Iniciar profilaxis con isoniazida
B) Iniciar rifampicina más isoniazida
C) Iniciar tratamiento habitual para la tuberculosis
D) Solicitar TAC de tórax
E) Esperar el resultado del cultivo de Koch y decidir conducta según resultado

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La radiografía no se veía bien, pero tanto por la PCR + para TBC, como por el quamtiferón positivo, probablemente se trata de una TBC, aunque las baciloscopías estén negativas y se debe iniciar el tratamiento habitual.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 118 · 1.04.1.028 · Tuberculosis extrapulmonar

Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que se inicia tratamiento con antibióticos asociados. Sus baciloscopías mensuales de control resultan: mes 1 (+), mes 2 (-), mes 3 (-), mes 4 (-), mes 5 (+) y mes 6 (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Recaída
B) Eliminación esporádica
C) Fracaso
D) Contaminación
E) Nocardiosis pulmonar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Dos BK (baciloscopías) positivas seguidas, después del cuarto mes, es sospechosa de fracaso a tratamiento. El diagnóstico de fracaso requiere del cultivo, pero las 2 BK positivas son suficientes para que se derive a tratamiento secundario, mientras está el resultado del cultivo de Koch y el antibiograma.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 118 · 1.04.1.011 · Enfermedades eruptivas no

Hombre de 18 años, sin antecedentes, con cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, que durante el último día se ha asociado a prurito generalizado. Al examen físico destaca presencia de lesiones papulares y vesículas muy pruriginosas en tronco y extremidades, no asociado a otros hallazgos. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Clorfenamina oral
B) Aspirina oral
C) Aciclovir oral
D) Vacuna contra virus herpes 3
E) Inmunoglobulina G no específica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Aciclovir oral** (opción **C**). Es una varicela en mayor de 13 años. La aspirina está contraindicada.. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 127 1.04.1.011 · Enfermedades eruptivas no

Una paciente de 41 años, con antecedente de VIH, con baja de peso, consulta por dolor y ardor en la zona derecha del dorso, que se irradia a la región mamaria ipsilateral. En el examen físico se observan vesículas en la espalda y en la mama derecha. El tratamiento de elección es:

A) Aciclovir
B) Cloxacilina
C) Mupirocina
D) Valganciclovir
E) Azitromicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un herpes zóster, que se trata con aciclovir o valaciclovir. El valganciclovir se usa en las infecciones por CMV.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 54 1.04.1.025 · Síndrome mononucleósico

Un paciente de 23 años consulta por fiebre de 7 días de evolución asociada a odinofagia intensa y malestar general. Al examen Fsico se observa paciente febril, con temperatura: 38,1 °C, frecuencia cardíaca: 100 por minuto y presión arterial: 118/78 mmHg; presenta faringe eritematosa con amígdalas aumentadas de tamaño, se palpan adenopa`as cervicales anteriores bilaterales y, en el examen abdominal, se palpa el hígado 2 cm por debajo del reborde costal. Se solicitan exámenes, destacando: hemograma con hematocrito 39%, hemoglobina 13 g/dL, VCM 88 fL, glóbulos blancos 15.600/mm³ con 70% linfocitos, 20% neutrófilos y 10% monocitos; pruebas hepá8cas con SGOT: 262 U/L, SGPT: 214 U/L, GGT: 90 U/L, fosfatasas alcalinas: 95 U/L y bilirrubina total: 1,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Infección por virus hepa22s A
B) Leucemia aguda
C) Toxoplasmosis aguda
D) Mononucleosis infecciosa
E) Amigdali2s bacteriana

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una mononucleosis clásica, con el síndrome mononucleósico (odinofagia, adenopaVas y fiebre), más los elementos clásicos: linfocitosis, hepatoesplenomegalia y hepaGGs (faltó el rash morbiliforme espontáneo o posterior al uso de aminopenicilinas).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 152 1.04.1.025 · Síndrome mononucleósico

Una paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, coriza y odinofagia. Al examen físico destacan amígdalas aumentadas de tamaño con exudado blanquecino adherente, adenopatías cervicales, examen pulmonar normal y abdominal con hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes que muestran lo siguiente: IgM VCA (+), IgG VCA (-), IgM CMV (-), IgG CMV (+), ELISA VIH (-). El diagnóstico más probable es:

A) Primoinfección por VIH
B) Mononucleosis por Citomegalovirus
C) Mononucleosis por Virus Epstein Barr
D) Síndrome mononucleósico por estreptococo pyogenes
E) Síndrome mononucleósico por leucemia aguda

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Mononucleosis por Virus Epstein Barr** (opción **C**). Tiene la IgM VCA positiva. La amigdalitis aguda es un tema frecuente en el EUNACOM, apareciendo tanto en otorrinolaringología como en pediatría e infectología. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 164 1.04.1.025 · Síndrome mononucleósico

Paciente de 17 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y odinofagia, de 7 días de evolución. Al examen, presenta lesiones blanquecinas en las amígdalas y congestión de la orofaringe, adenopatías cervicales y se palpa el bazo moderadamente aumentado de tamaño. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Adenovirus
B) Virus influenza
C) Virus de Ebstein Barr
D) Citomegalovirus
E) Estreptococo A

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una mononucleosis clásica, causada por el VEB. La esplenomegalia hace que no sea una faringitis estreptocócica, sino una mononucleosis, con seguridad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 169 1.04.1.025 · Síndrome mononucleósico

Paciente 18 años con +7 días? faringe eritematosa, adenopatías, múltiples consultas por el cuadro, le dieron amoxicilina. Al examen físico persiste con adenopatías, tenía un exantema rosado??. Conducta: a. Solicitar Elisa VIH

B) IGM anti cápside epstein barr
B) Hemograma y VHS
C) Ecografía
D) Radiografía
E) TAC con contraste

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **IGM anti cápside epstein barr** (opción **B**). 90% de las amigdalitis son virales → tratamiento sintomático. Solo las bacterianas requieren antibióticos. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 141 1.04.1.016 · Influenza

En contexto de un brote de influenza, durante el invierno, un paciente de 22 años presenta un cuadro de rinorrea, congestión nasal, fiebre, mialgias generalizadas y tos seca. Al examen físico presenta 39 grados celsius, con examen pulmonar normal. El tratamiento más adecuado es:

A) Oseltamivir
B) Zanamivir
C) Aciclovir
D) Valaciclovir
E) Paracetamol

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta demasiado discutible, ya que los pacientes sin antecedentes de riesgo tienen la opción de usar oseltamivir, si así lo quieren, para disminuir el tiempo de influenza y asegurar que no será grave. La guía minsal solo da oseltamivir a pacientes con factores de riesgo o con influenza grave. Sin embargo el tratamiento sintomático es el de elección en la influenza. Se debe evitar la aspirina y el ibuprofeno, por el riesgo de síndrome de Reye. Además por la rinorrea y congestión, se puede sospechar otro virus, distinto a la influenza

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 156 1.04.1.016 · Influenza

Paciente de 66 años, hipertenso en tratamiento, consulta por cuadro de 3 días de compromiso del estado general, sensación febril, tos y coriza, síntomas que se han hecho más intensos en las últimas horas agregándose cefalea y mialgias intensas. Su examen físico muestra temperatura de 38,5ºC, examen pulmonar sin alteraciones. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

A) Acetaminofeno
B) Oseltamivir
C) Claritromicina
D) Zanamivir
E) Ibuprofeno

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una influenza (adulto mayor). Mayor de 60 años es indicación de oseltamivir. Sin embargo el tratamiento de elección para la influenza es el tratamiento sintomático, además que lleva 3 días, por lo que el oseltamivir es menos efectivo. Ambas son respuestas correctas. Es una pregunta muy discutible, pero si la pregunta es cuál es el tratamiento de la influenza, la respuesta es: paracetamol. No les puedo prometer que esta haya sido la respuesta. Lean las páginas 6 y 7 del siguiente link: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/GUIA%20CLINICA%20INFLUENZA%202014_imprimir.pdf

---

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 100 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Un paciente de 24 años mantiene relación sexual casual hace 7 días, con penetración vaginal, sin protección evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Mycoplasma genitalium
B) Ureaplasma urealyticum
C) Chlamydia trachomatis
D) Trichomona vaginalis
E) Escherichia coli

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta difícil, ya que A, B, C y D pueden producir ese cuadro clínico. Sin embargo, la Chlamydia es la causa más frecuente de uretritis, después de la gonorrea (la que bastante purulenta, casi siempre; mientras que las demás pueden no serlo).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 61 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Un hombre de 34 años consulta por disuria, asociada a secreción uretral purulenta, de un día de evolución. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección hace una semana. Se realiza tinción de Gram de la secreción uretral, observándose abundantes cocáceas Gram negativas intra y extracelulares. El agente etiológico más probable es:

A) Neisseria gonorrhoeae
B) Treponema pallidum
C) Chlamydia trachomatis
D) Mycoplasma genitalium
E) Streptococcus pyogenes

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las cocáceas G(-) intracelulares son gonococo. Se debe tratar con ceftriaxona IM (259 mg por una vez), pero, además, se debe cubrir Chlamydia con doxiciclina o azitromicina o doxiciclina.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 110 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Un paciente de 24 años mantiene relaciones sexuales, por vía vaginal, sin protección, evolucionando con disuria, sin otros síntomas. Al examen físico y genital, no hay alteraciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Trichomona vaginalis
B) Treponema pallidum
C) Ureaplasma urealyticum
D) Mycoplasma genitalis
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta pésima, puede ser cualquiera de las opciones, menos la B. Sin embargo, la causa más frecuente de uretritis no gonocócica es la Chlamydia trachomatis. Si bien le falta clínica para tener una uretritis (solo tiene disuria, sin secreción uretral), pareciera que es lo que se está preguntando, dadas las alternativas.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 36 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Hombre de 25 años con secreción uretral purulenta y disuria de 4 días de evolución. Tinción de Gram: diplococos gram negativos intracelulares. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Azitromicina 1 g oral dosis única
B) Doxiciclina 100 mg c/12h por 7 días
C) Ciprofloxacino 500 mg oral dosis única
D) Amoxicilina 3 g oral dosis única
E) Ceftriaxona 500 mg IM dosis única

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Gonorrea uretral: ceftriaxona 500 mg IM dosis única es el tratamiento de elección (guías CDC 2021). Alta resistencia a ciprofloxacino y amoxicilina. Se agrega azitromicina o doxiciclina para cubrir Chlamydia concomitante (coinfección en ~40% de casos).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 37 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Hombre de 30 años consulta por úlcera indolora en glande de 5 días de evolución, bordes indurados, fondo limpio. Sin adenopatías inguinales dolorosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sífilis primaria (chancro sifilítico)
B) Herpes genital
C) Chancroide (Haemophilus ducreyi)
D) Linfogranuloma venéreo
E) Carcinoma espinocelular de pene

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Úlcera genital única, indolora, bordes indurados, fondo limpio = chancro sifilítico (sífilis primaria por Treponema pallidum). El herpes es doloroso y con vesículas; el chancroide es doloroso.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 136 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Un paciente consulta porque hace 3 días notó aparición de una úlcera en el pene, ubicada en el glande, de 1 cm de diámetro, de aspecto indurado, fondo limpio y sin otros síntomas. Además, se palpa una adenopatía inguinal derecha indolora. Se solicita VDRL y FTA-ABS, resultando ambos negativos. El diagnóstico más probable es:

A) Sífilis primaria
B) Chancroide
C) Enfermedad de Behcet
D) Infección por virus papiloma humano
E) Linfogranuloma venéreo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un chancro o sífilis primaria clásica. Es frecuente que las pruebas treponémicas y no treponémicas estén negativas al inicio, por lo que el diagnóstico es clínico (a lo más se confirma con una microscopía de campo oscuro).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 169 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Una paciente de 19 años consulta por disuria dolorosa y lesiones vulvares, de 48 horas de evolución. Refiere relaciones sexuales sin protección. Al examen genital, tiene 3 úlceras de fondo amarillento y halo eritematoso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Molusco contagioso
B) Infección por Chlamydia trachomatis
C) Herpes genital
D) Chancro sifilítico
E) Condiloma acuminado

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Herpes genital** (opción **C**). [Pregunta disputada] Es un herpes genital clásico.. La artritis reactiva es una pelvispondiloartropatía que ocurre 1-4 semanas después de una infección. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 86 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Una mujer de 26 años, sexualmente activa y alérgica a la penicilina, consulta por disuria y molestias genitales, de 4 días de evolución, asociada a leucorrea. Al examen físico, se observan signos inflamatorios en el cuello uterino, con escasa leucorrea. El cultivo de Thayer Martin es positivo y prueba de aminas, negativa. El tratamiento de elección es:

A) Ciprofloxacino
B) Ceftriaxona
C) Azitromicina
D) Doxiciclina
E) Penicilina benzatina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una uretritis y cervicitis gonocócica (cultivo de Thayer Martin positivo) y, por tanto, se debe tratar con ceftriaxona de elección. La azitromicina y el ciprofloxacino también sirven, pero sigue siendo de elección la ceftriaxona. Es cierto que también se debe cubrir Chlamydia, por lo que la única respuesta que cubre todo es la azitromicina, pero se debe simplificar el enfrentamiento de esta pregunta, en que específicamente se pregunta el tratamiento de la gonorrea y, por ello, la respuesta es la B.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 91 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

¿Cuál es la conducta más adecuada ante un hombre joven, que presenta múltiples condilomas acuminados perianales?

A) Descartar otras enfermedades de transmisión sexual
B) Determinar el genotipo del virus papiloma
C) Realizar rectosigmoidoscopía
D) Realizar tratamiento con podofilino
E) Indicar aciclovir oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Lo más importante en toda ETS es descartar otras ETS, en particular en los condilomas, que no tienen mayores complicaciones.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 145 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Una paciente de sexo femenino de 17 años de edad, con antecedente de relaciones sexuales sin protección, consulta prurito vulvar, asociado a ardor progresivo. Refiere sensación de aumento del volumen de la vulva, que luego fue seguido por los síntomas actuales. Al examen físico se observa lo expuesto en la siguiente imagen. Se trata de una infección por:

A) Treponema pallidum
B) Virus herpes simplex
C) Chlamydia tracomatis
D) Virus papiloma humano
E) Ureaplasma urealyticum

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Virus herpes simplex). Es un herpes genital clásico.. La artritis reactiva es una pelvispondiloartropatía que ocurre 1-4 semanas después de una infección. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 52 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Una mujer de 23 años consulta por disuria de 7 días de evolución asociada a dolor abdominal bajo. En su examen ginecológico 8ene especuloscopía con cuello uterino cerrado y sin lesiones y con paredes vaginales sin alteraciones. Al tacto vaginal presenta dolor a la compresión anterior de la vagina. Se solicita sedimento de orina, que muestra presencia de piuria y leucocituria y un urocul8vo, que resulta nega8vo a las 24 horas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar urocul2vo de 2empo extendido
B) Solicitar UroTAC
C) Solicitar cistoscopía
D) Iniciar flavoxato vía oral
E) Solicitar panel de reacción de cadena de polimerasa para ITS

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una uretriGs por Chlamydia (más raro gonococo), dada la disuria con piuria aséptica y el dolor a la palpación uretral (zona anterior de la vagina). Además de solicitar la PCR para ITS, se debe iniciar tratamiento empírico con 1 dosis de cemriaxona (gonococo) + 10 días de doxicilina (clamidia), siendo una opción la azitromicina en monodosis. La piuria aséptica (sedimento con piuria + urocultivo negativo) también se ve en la tuberculosis renal y en las ITU en las que se iniciaron antibióticos antes de tomar el urocultivo.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 112 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Un paciente de 23 años, con antecedente de relación sexual sin protección, consulta porque hace 3 días notó aparición de una úlcera en el pene, ubicada en el glande, indolora, de 1 cm de diámetro, de aspecto indurado. Además, se palpa una adenopatía inguinal derecha indolora. Se solicita VDRL y FTA-ABS, resultando ambos negativos. El diagnóstico más probable es:

A) Sífilis primaria
B) Chancroide
C) Enfermedad de Behcet
D) Herpes genital
E) Linfogranuloma venéreo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un chancro clásico, cuyo diagnóstico es clínico (úlcera indolora) precisamente porque las pruebas suelen salir negativas al inicio (treponémicas y no treponémicas).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 40 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Mujer con úlcera indolora en la horquilla vulvar y adenopatías inguinales. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Penicilina benzatina
B) Aciclovir oral
C) Metronidazol oral
D) Doxiciclina por 21 días
E) Ceftriaxona IM dosis única

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Penicilina benzatina** (opción **A**). Penicilina benzatina. Tratamiento: AINEs (primera línea) + corticoides (segunda línea, a diferencia de otras PEA donde son biológicos) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 178 1.04.1.010 · Enfermedades de transmisió

Una mujer de 25 años, quien mantuvo relaciones sexuales sin protección hace 3 semanas, consulta porque notó aparición de una lesión genital, que se observa como una úlcera en la horquilla vulvar. Además, se palpa una adenopatía inguinal izquierda. No ha tenido otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tratarla con penicilina benzatina
B) Solicitar PCR para virus herpes simplex
C) Tratar con fluconazol oral
D) Tratar con aciclovir
E) Tratar con doxicilina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Tratarla con penicilina benzatina** (opción **A**). Tratamiento: AINEs (primera línea) + corticoides (segunda línea, a diferencia de otras PEA donde son biológicos) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 2 1.04.4.016 · Serología de enfermedades

Una paciente de 25 años, embarazada, con 12 semanas contadas desde la FUR segura y confiable, se realiza exámenes, entre los que trae un VDRL, que resulta "no reactivo" y un MHA-TP, que resulta "reactivo". ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar penicilina benzatina de inmediato
B) Realizar VDRL mensual durante el resto del embarazo
C) Controlar con VDRL a las 30 semanas
D) Solicitar un FTA-ABS
E) Indicar doxiciclina vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Sífilis tratada: Las pruebas no treponémicas (VDRL, RPR) se negativizan tras tratamiento exitoso. Las treponémicas (FTA-ABS, MHA-TP) permanecen positivas de por vida. VDRL no reactivo + MHA-TP reactivo indica sífilis tratada. Conducta: control prenatal habitual + VDRL entre las 28-30 semanas.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 122 1.04.4.016 · Serología de enfermedades

Una paciente se realiza exámenes, ya que su pareja fue diagnosticada de hepatitis B. Tiene antígeno de superficie para VHB negativo y anticuerpos anti-VHBsuperficie positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vacunada contra la hepatitis B
B) Hepatitis B aguda
C) Hepatitis B crónica
D) Hepatitis B en periodo de ventana
E) Infección asintomática por virus hepatitis B

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene antígeno negativo (no tiene hepatitis B) y tiene anticuerpos antisuperficie positivos (está protegido). O está vacunado o tuvo hepatitis B y se mejoró.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 70 1.04.4.016 · Serología de enfermedades

Una paciente de 25 años, embarazada, con 12 semanas contadas desde la FUR segura y confiable, se realiza exámenes, entre los que trae un VDRL, que resulta “no reactivo” y un MHA-TP, que resulta “reactivo”. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar penicilina benzatina de inmediato
B) Realizar VDRL mensual durante el resto del embarazo
C) Controlar con VDRL a las 30 semanas
D) Solicitar un FTA-ABS
E) Indicar doxiciclina vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Sífilis tratada: Para el diagnóstico de sífilis se utilizan dos tipos de pruebas serológicas: pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas, como el VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) y el RPR (Rapid Plasma Reagin), suelen negativizarse después del tratamiento exitoso de la sífilis. Las pruebas treponémicas, como el FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption) y el MHA-TP (Micro-Hemagglutination Assay for Treponema pallidum), permanecen positivas de por vida, incluso después del tratamiento. En el caso descrito, los resultados sugieren que la paciente tuvo sífilis en el pasado y se curó con tratamiento. Por lo tanto, la conducta a seguir es realizar el control prenatal habitual, incluyendo una nueva prueba de VDRL entre las 28 y 30 semanas de gestación.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 5 1.04.4.016 · Serología de enfermedades

Un paciente de 26 años consulta por aparición de una lesión en los genitales. Tiene antecedente de relaciones sexuales de riesgo, con múltiples parejas sexuales. Al examen físico tiene una lesión ulcerada de 1 cm, en el glande, indolora, de aspecto limpio. Además, se palpan pequeñas adenopatías inguinales bilaterales, indoloras. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Tinción de Gram de la secreción de la lesión
B) VDRL
C) Reacción de polimerasa para Chlamydia trachomatis
D) Reacción de polimerasa para virus herpes simplex
E) Reacción de polimerasa para virus papiloma humano

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un chanco o sífilis primaria clásica. Por tanto, no requiere ningún examen, ya que el diagnóstico es clínico y los exámenes suelen estar normales. A lo más, se confirma con una microscopía de campo oscuro. Sin embargo, la única opción concordante con sífilis es la B y, sea como sea, es necesario para el seguimiento de la respuesta al tratamiento (debería negativizar, si es que positiviza).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 119 1.04.4.016 · Serología de enfermedades

Una mujer de 24 años, parvularia, cursando embarazo de 18 semanas, estuvo en contacto con un niño, que fue recientemente diagnosticado de varicela. Ella refiere que nunca ha tenido varicela. No presenta síntomas ni alteraciones en su examen físico u obstétrico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar aciclovir a la madre
B) Solicitar serología para la varicela a la madre
C) Administrar gamaglobulina hiperinmune contra varicela a la madre
D) Vacunar contra la varicela
E) Observar evolución

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar serología para la varicela a la madre** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 124 1.04.1.019 · Micosis invasora

Un paciente de 41 años, diabético tipo 1, consulta por fiebre, asociado a rinorrea purulenta y enrojecimiento facial. Al examen físico, se observa eritema de la mejilla izquierda y de la punta de la nariz, con una zona necrótica en el ala nasal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Stafilococcus aureus
B) Candida albicans
C) Streptococcus pyogenes
D) Mucor
E) Pseudomona aureginosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Mucor). Es una mucormicosis clásica.. Las causas de hipoglicemia se dividen en dos grandes grupos: en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 132 1.04.1.019 · Micosis invasora

Un paciente, con antecedente de leucemia mieloide crónica, en quimioterapia hace 2 semanas, presenta un cuadro de tos, con expectoración purulenta, con estrías de sangre, asociada a fiebre y malestar general. Se solicitan exámenes, entre los que destaca VHS: 90 mm/h, PCR: 22 mg/L. Se realiza TAC de tórax, que visualiza una tumoración densa, con un halo radiolúcido. El agente etiológico más probable es:

A) Pseudomona aureginosa
B) Aspergillus
C) Staphilococcus aureus
D) Candida albicans
E) Mycobacterium tuberculosis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una aspergilosis pulmonar clásica. Previamente se había preguntado, con la radiografía, que mostraba el aspergiloma clásico, que en este caso solo se describe. Suele elevar mucho la VHS y se ve tanto en pacientes inmunosuprimidos (como en este caso), como en pacientes con lesiones bronquiales (bronquiectasias o cavernas tuberculosas).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 73 1.04.1.019 · Micosis invasora

Paciente con diagnóstico de una leucemia mieloide aguda, en su cuarto ciclo de quimioterapia, se encuentra hospitalizado por fiebre sin foco, asociado a neutropenia (neutropenia febril), por lo que está en tratamiento con ceftazidima, amykacina y vancomicina, sin mayor respuesta. En sus exámenes de laboratorio presenta neutrófilos 100 por mm3 y en la radiografía de tórax se observa una imagen apical derecha radiopaca, de 3 cm de diámetro, espiculada y con bordes difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis
B) Neumonía intrahospitalaria
C) Aspergilosis invasiva
D) Nocardosis
E) Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La aspergilosis es una complicación clásica de la neutropenia prolongada. Además, por ser un hongo, no responde a los antibióticos.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 40 1.04.1.019 · Micosis invasora

Un paciente de 35 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expec- toración que ha ido empeorando, agregándose disnea importante. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 35 por minuto, frecuencia cardia- ca de 92 por minuto, presión arterial de 100/70mmHg y saturación de 93% con FiO2 am- biental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bila- terales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
B) Bronquitis chlamydia trachomatis
C) Tuberculosis pulmonar
D) Neumonía por mycoplasma
E) Neumonía por pneumocystis jiroveci

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto el cuadro clínico, como la RxTx con compromiso bilateral hacen sospechar una infección por VIH más Pneumocystis.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 29 1.04.1.019 · Micosis invasora

Un hombre de 29 años, presenta un cuadro de tos seca, de 5 semanas de evolución, a lo que se ha agregado disnea y malestar general. Al examen físico destaca FC: 100x', PA: 110/70 mmHg, temperatura: 37,5 grados Celsius y FR: 30x'. El examen cardiopulmonar, así como la radiografía de tórax son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infección por adenovirus
B) Infección por virus influenza
C) Infección por Bordetella pertusis
D) Infección por Pneumocystis jiroveci
E) Infección por Mycobacterium tuberculosis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta difícil. Parece una infección por Pneumocystis en un paciente VIH, tan inmunosuprimido que no condensa la radiografía. El tiempo de evolución hace imposible el ADV y la influenza (son agudos y de corta evolución). La tos es compatible con Bordetella, pero no la fiebre ni la disnea. Finalmente, no tiene clínica ni radiografía de TBC (falta expectoración, fiebre alta y RxTx alterada).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 62 1.04.1.023 · Sífilis secundaria, tercia

Un paciente es diagnosticado de infección por VIH, hace 3 meses. Está en etapa A3 e inició tratamiento con triterapia antirretroviral al momento del diagnóstico. Consulta ahora por aparición de placas pruriginosas en el tronco, más algunas lesiones similares en las palmas y plantas. Además tiene una lesión parecida en la cara interna de la mejilla derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pitiriasis rosada
B) Pitiriasis versicolor
C) Síndrome pie mano boca
D) Sífilis secundaria
E) Reacción adversa a la triterapia antirretroviral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una sífilis secundaria clásica. Además recordar que el principal factor de riesgo para tener una ETS, es tener otra ETS.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 27 1.04.1.023 · Sífilis secundaria, tercia

Una mujer embarazada de 8 semanas se toma un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/64. Tiene antecedente de alergia a la amoxicilina. El tratamiento de elección es:

A) Penicilina
B) Clindamicina
C) Ceftriaxona
D) Eritromicina
E) Doxiciclina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Eritromicina** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Penicilina, Clindamicina) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 130 1.04.1.023 · Sífilis secundaria, tercia

Una paciente de 25 años, con antecedente de sífilis tratada hace un año, cursando un embarazo de 8 semanas, se realiza un VDRL, que resulta positivo en dilución 1/16. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar FTA-ABS
B) Controlar con VDRL seriado
C) Solicitar RPR
D) Administrar ceftriaxona
E) Administrar penicilina benzatina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Debe tratarse por cualquier de las dos siguientes razones: 1. Todo VDRL positivo en el embarazo se trata, incluso antes de confirmarse con las pruebas treponémicas. 2. Alguien que ya tuvo sífilis mantendrá siempre positivas las pruebas treponémicas (FTA-ABS o MHA-TP), por lo que basta que vuelvan a positivizar las pruebas no treponémicas (VDRL o RPR) para indicar tratamiento.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 37 1.04.1.023 · Sífilis secundaria, tercia

Mujer de 25 años, con embarazo de 15 semanas, presenta un VDRL positivo en dilución 1/16. Refiere ser alérgica a la amoxicilina, con una reacción alérgica, que requirió hospitalización, cuando presentó una infección faríngea en la infancia. La conducta más adecuada es:

A) Tratar con penicilina benzatina, administrando una dosis ahora y otra en una semana.
B) Pedir ANA y anticuerpos anti-DNA
C) Solicitar FTA-abs
D) Tratar con eritromicina
E) Tratar con cefriaxona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Todo VDRL positivo en el embarazo se debe tratar de inmediato, sin esperar la confirmación, aunque sí se confirma con FTA-abs posteriormente. Por ser alérgica a la penicilina, con reacción grave, están contraindicadas la penicilina y la ceftriaxona. La eritromicina y otros macrólidos es el tratamiento de elección de la sífilis en alérgicos y la eritromicina es el macrólido de elección en el embarazo. La recomendación norteamericana es, además, desensibilizar contra la penicilina y tratar con penicilina. Sin embargo, la recomendación del Minsal es eritromicina.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 72 1.04.1.013 · Hidatidosis

Un hombre de 40 años presenta un cuadro de dolor abdominal, de 3 meses de evolución, leve, intermitente. Al examen físico presenta leve dolor a la palpación del hipocrondrio derecho, por lo que se solicita una ecografía de abdomen, que visualiza una lesión hepática quística, con paredes visibles y gruesas, de 8 cm. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito y plaquetas normales, con 8.000 blancos, 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos, 3% de eosinófilos y 7% de monocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) IgG para Toxoplasma gondii
B) Serología para hidatidosis
C) Serología para Triquinella spiralis
D) IgG para Fasciola hepática (Distoma)
E) Examen parasitológico seriado de deposiciones

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un quiste hidatídico con el patrón ecográfico clásico (lesión quística con paredes y/o tabiques). El diagnóstico se confirmó ya con la Ecografía, pero la serología puede ayudar a confirmarlo y además sirve para el seguimiento postquirúrgico (en que deben disminuir los niveles de anticuerpos). Además, era la única opción relacionada con el diagnóstico.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 70 1.04.1.013 · Hidatidosis

Un paciente de 34 años presenta un episodio de tos intensa, con salida de abundante líquido salobre, con presencia de membranas blanquecinas y restos hemoptoicos. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?

A) TAC de tórax y abdomen
B) Parasitológico de deposiciones
C) Radiografía de tórax
D) Ecografía abdominal
E) Colonoscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una vómica, cuadro clásico de la hidatidosis pulmonar. El primer examen siempre es la radiografía de tórax. Luego se puede seguir con TAC y/o ecografía abdominal, en busca de lesiones hepáticas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 123 1.04.2.003 · Endocarditis bateriana

Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular, secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene T°: 38,2°C, PA: 120/80 mmHg, FC: 94x', se observan lesiones eritematosas en los dedos de ambas manos y algunas petequias en las extremidades inferiores y, en el examen cardíaco, se aprecia un soplo diastólico de intensidad IV/VI. Se solicitan exámenes de sangre, entre los que destaca PCR: 12 mg/L, VHS: 70 mm/h y leucocitosis de 16.000 por mm3. Además, se realizan 3 hemocultivos, que resultan todos positivos para cocáceas Gram positivas, en cadena. ¿Cuál es el antibiótico de elección para iniciar el tratamiento?

A) Penicilina sódica
B) Cloxacilina
C) Clindamicina
D) Ceftazidima
E) Gentamicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una endocarditis subaguda por Streptococcus viridans, que se trata con ampicilina o penicilina sódica.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 136 1.04.2.003 · Endocarditis bateriana

Paciente operado de válvula cardíaca hace 2 meses. Presenta fiebre, soplo cardíaco nuevo y hemocultivos positivos. ¿Cuál es el agente más probable en endocarditis infecciosa post-cirugía cardíaca precoz?

A) Staphylococcus aureus o S. epidermidis
B) Streptococcus viridans
C) Enterococcus faecalis
D) HACEK group
E) Candida albicans

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Endocarditis protésica precoz (<2 meses post-cirugía): causada por gérmenes hospitalarios, principalmente Staphylococcus aureus y S. epidermidis (estafilococos coagulasa negativos), adquiridos intraoperatoriamente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 115 1.04.2.003 · Endocarditis bateriana

Paciente masculino de 45 años, presenta súbitamente hemiparesia derecha, refiere historia de 2 meses de evolución de astenia, compromiso del estado general y fiebre de predominio nocturno. Al examen físico presenta hemiparesia derecha, fiebre de 37,8 grados celsius y la auscultación cardiaca muestra un ritmo regular en 2 tiempos, con un soplo sistólico IV/VI en el ápex. Su sedimento de orina muestra hematuria microscópica. El diagnóstico más probable es:

A) Absceso cerebral
B) Tuberculosis meníngea
C) Meningitis bacteriana
D) Endocarditis bacteriana
E) Leucemia mieloide aguda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto el soplo, como los fenómenos embólicos, orientan a EBSA (endocarditis bacteriana subaguda; la aguda es menor a 7 días). Ninguna de las opciones puede ser, por no tener relación con la clínica.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 81 1.04.3.009 · Profilaxis de tuberculosis

Una paciente de 39 años, inmigrante, VIH positiva sin tratamiento desde hace 2 años, consulta por síntomas respiratorios, que comenzaron hace 3 semanas, consistentes en tos con expectoración mucopurulenta, fiebre y malestar general. Ha utilizado amoxicilina automedicada, sin respuesta. Al examen físico está enflaquecida. El examen pulmonar se auscultan estertores y crépitos en el lóbulo superior derecho. Se solicita PPD, que resulta 5 mm; baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; y se toma cultivo líquido MGIT, que resultó positivo a los 15 días. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radio): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar tratamiento profiláctico para la tuberculosis
B) Iniciar tratamiento estándar para la tuberculosis
C) Esperar el resultado del cultivo estándar para mycobacterias
D) Reiniciar la triterapia antirretroviral
E) Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar tratamiento profiláctico para la tuberculosis** (opción **A**). Baciloscopías de expectoración: examen de elección; pedir 3-4; sensibilidad 80%; muestra válida si > 50 neutrófilos/campo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 16 1.04.3.009 · Profilaxis de tuberculosis

Una paciente de 30 años, asintomática, está cursando un embarazo de 20 semanas. Su marido fue recientemente diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante baciloscopías de expetoración que resultaron (+++). La mujer se realiza baciloscopías, que son negativas y un PPD que resulta 26 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada para con ella?

A) Mantener una conducta expectante como protección fetal
B) Iniciar tratamiento con 4 fármacos (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol).
C) Repetir las baciloscopías periódicamente
D) Administrar la vacuna BCG
E) Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta demasiado específica y no debería preguntarse. Sin embargo, una embarazada con contacto con un paciente bacilífero y PPD positivo, tiene indicación de profilaxis para TBC.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 142 1.04.3.009 · Profilaxis de tuberculosis

¿Cuál es la conducta más adecuada para un paciente, que es contacto intradomiciliario de otro individuo diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera?

A) Solicitar PPD y cultivo de expectoración
B) Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías
C) Controlar clínicamente por 3 meses
D) Indicar profilaxis con isoniazida por 6 meses
E) Solicitar cultivo de Koch y broncoscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El manejo actual de los contactos de TBC es solicitar radiografía, baciloscopías y consultar la presencia de síntomas. Además, se puede pedir el PPD (obligatorio en menores de 15 años): si está positivo y todo el resto normal, se deja profilaxis por 6 meses con isoniazida. Si las BK están positivas, se trata con los 4 ATB antiTBC (en el menor de 15 años, también si es que tiene la RxTx alterada).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 17 1.04.4.007 · Cultivo de expectoración

Un paciente 2 meses de malestar general, tos con expectoración, sensación febril, baja de peso y sudoración. Además, en el último tiempo ha aumentado la tos y ha presnetado expectoración hemoptoica. Solicita un hemograma que muestra leucocitosis de 15.000 glóbulos blancos por mm3 y se solicita una radiografía que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía de tórax AP, con afectación de ambos lóbulos superiores, mayor al lado izquierdo, con una banda atelectásica en el ápice izquierdo). ¿Cuál es el examen más adecuado ante la sospecha diagnóstica?

A) Broncoscopía
B) Baciloscopías de expectoración más cultivo de Koch
C) TAC de tórax
D) Cultivo de expectoración
E) Hemocultivos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Baciloscopías de expectoración más cultivo de Koch** (opción **B**). Tiene clínica de TBC y la RxTx era sugerente.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 65 1.04.4.007 · Cultivo de expectoración

Un paciente de 35 años, en situación de calle, con antecedente poliadicciones, presenta un cuadro de 2 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general, disnea de esfuerzos, baja de peso y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido con peso 52 Kg, pálido, con edema de extremidades inferiores, T°: 37,2°C, FC: 87x', PA: 90/60 mmHg, FR: 15x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, leucocitos: 15.000 por mm3, VHS: 50 mm/h, PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio?

A) TAC de tórax
B) Videotoracoscopía
C) PPD
D) Baciloscopías de expectoración
E) Fibrobroncoscopía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una tuberculosis clásica, tanto por la clínica como por la radiografía. Si bien el cáncer también es compatible, la edad, la situación de calle, la elevación de los parámetros inflamatorios, la secreción mucopurulenta, la fiebre y la radiografía orientan más a TBC.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 140 1.04.4.007 · Cultivo de expectoración

Un paciente con diagnóstico de tuberculosis activa inicia tratamiento antituberculoso con un esquema primario. Al tercer mes de tratamiento, se realiza un control y se observa que las baciloscopías mensuales han permanecido positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Respuesta clínica esperable
B) Fracaso del tratamiento
C) Recaída de la tuberculosis
D) Infección por micobacterias atípicas
E) Aspergilosis pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Control de Tratamiento de Tuberculosis: Es normal que las baciloscopías se mantengan positivas hasta el tercer mes de tratamiento para la tuberculosis. El diagnóstico de fracaso al tratamiento se realiza con un cultivo positivo a partir del cuarto mes y se sospecha si la baciloscopía continúa positiva hasta el cuarto mes.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 106 1.04.1.006 · Celulitis bacteriana

Una paciente de 30 años presenta una caída, con erosión de la rodilla derecha. Us- ted la evalúa 3 días después, observándose una zona eritematosa que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes parcialmente definidos. ¿Cuál es el tratamiento más ade- cuado?

A) Curación con suero fisiológico y cobertura con apósito
B) Curaciones con povidona yodada
C) Mupirocina tópica
D) Amoxicilina oral por 7 días
E) Cefadroxilo oral por 7 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una infección de una herida abrasiva. Como los bordes son parcialmente definidos, no queda claro si es una celulitis o una erisipela. Afortunadamente el cefa-

---

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 74 1.04.1.006 · Celulitis bacteriana

Tratamiento de elección para paciente afebril y en BCG, con forúnculo con cultivo de secreción: S. Aureus Resistente a: Clinda / Cefa; Sensible a Linezolid / Vanco a. Drenaje b. Hospitalizar y Vancomicina ev

C) Linezolid vo
B) Amoxicilina
C) Ibuprofeno
D) Paracetamol
E) Omeprazol

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Linezolid vo** (opción **C**). Alergia a penicilina mediada por IgE: reaccion inmediata (urticaria leve a anafilaxia grave) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 25 · 1.04.1.022 · Parasitosis intestinales

IMAGEN: Parásito intestinal (foto taenia SAGINATA) tratamiento:

A) Mebendazol
B) Albendazol
C) Praziquantel
D) Ivermectina
E) Derrame pleural

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Praziquantel** (opción **C**). La hipercolesterolemia familiar es la dislipidemia genética más importante para el EUNACOM De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 101 · 1.04.1.022 · Parasitosis intestinales

Paciente de 45 años con diarrea crónica de 6 meses. Se realiza colonoscopía que muestra imágenes de parásitos adheridos a la mucosa del colon ascendente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Giardia lamblia (duodenal, no colónica)
B) Entamoeba histolytica (colitis amebiana)
C) Trichuris trichiura (tricocefalosis)
D) Ascaris lumbricoides (se ve en intestino delgado)
E) Cryptosporidium (microscópico, no visible)

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Trichuris trichiura (tricocefalosis): parásito de aspecto de "látigo" visible en colonoscopía adherido a la mucosa del ciego y colon ascendente. Causa diarrea crónica y en infecciones masivas, disentería. Tratamiento: albendazol 400 mg dosis única o mebendazol.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 23 · 1.04.1.022 · Parasitosis intestinales

Una paciente de 28 años consulta ya que lleva varios días eliminando restos de un parásito en sus deposiciones. Se solicita examen parasitológico de deposiciones, que muestra presencia de huevos operculados. ¿Cuál es el antecedente que debe preguntarse dirigidamente para establecer el diagnóstico?

A) Consumo de mariscos crudos
B) Consumo de sushi de salmón
C) Consumo de carne de vaca cruda
D) Viaje al caribe
E) Contacto con roedores

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Teniasis: La presencia de restos del parásito sugiere una infestación por una tenia. De las tenias, solo el Difilobotrium latum tiene huevos operculados y se transmite por el consumo de pescado crudo. El consumo de carne de vaca cruda puede producir una infestación por Taenia saginata, mientras que la carne de cerdo cruda puede transmitir la Taenia solium. Ambas tienen huevos no operculados.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 134 · 1.04.1.022 · Parasitosis intestinales

Un paciente de 40 años, con antecedente de infección crónica por VIH, diagnostica- do hace varios años, sin tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses, de tipo acuoso, sin fiebre, asociado a dolor abdominal. Al examen físico está afebril y presenta abdo- men balndo, depresible, levemente doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Salmonella sp.
B) Shigella sp.
C) Criptococcus
D) Microsporidium
E) Toxoplasma gondii

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta que induce a error. El Criptosporidium es la causa más frecuente de diarrea en el VIH. Sin embargo el criptococo no produce diarrea, sino meningitis y neu- monía. POr otro lado el microsporidium puede producir diarrea, pero su rol patológico es algo muy discutido.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 167 · 1.04.1.022 · Parasitosis intestinales

Una paciente de 25 años presenta dolor epigástrico intenso, asociado a vómitos, de 2 días de evolución, que inició luego de comer ceviche. Al examen físico tiene signos vitales normales y su examen abdominal muestra dolor a la palpación epigástrica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Ascaris lumbricoides
B) Entoamoeba histolytica
C) Anisakis simplex
D) Fasciola hepatica
E) Enterobius vermicularis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una anisakiasis clásica, que se produce por consumir pescado crudo y cursa con dolor gástrico y vómitos de pocos días de duración.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 168 · 1.04.1.022 · Parasitosis intestinales

Una adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales y al fondo de ojo, se observa una lesión blanquecina, redonda e hiperreflectante en la retina derecha, de 3 mm de diámetro. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra dos lesiones quísticas de 1 y 3 cm, ubicadas en la zona frontotemporal. Se realiza una punción lumbar, que muestra líquido claro, con proteínas 60 mg/dl, 70 células por mm3, con 80% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste aracnoidal
B) Hidatidosis cerebral
C) Encefalitis por virus herpes simplex
D) Encefalitis por virus varicela zóster
E) Neurocisticercosis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una neurocisticercosis clásica, con mucha información que orienta a ello (imagen clásica, eosinorraquia, fondo de ojo con visualización de cisticerco).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 122 1.04.3.005 · Prevención de infecciones

Un paciente de 90 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, por lo que está institucionalizado. Presentó un cuadro de obstrucción urinaria aguda, secundaria a una hiperplasia prostática benigna, por lo que se instaló una sonda Foley a permanencia, la que se cambia cada 30 días. El último cambio se realizó hace 15 días y posteriormente se realizó un urocultivo, que resultó positivo para Escherichia coli multisensible. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar ciprofloxacino
B) Realizar cistoscopía
C) Cambiar la sonda
D) Observar evolución
E) Derivar a cirugía abierta de la uropatía obstructiva

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Observar evolución** (opción **D**). Tiene una bacteriuria asintomática, por lo que no es necesario hacer ningún cambio.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 171 1.04.1.021 · Osteomielitis

Un niño de 7 años es hospitalizado para manejo quirúrgico de una osteomielitis. El antibiograma informa desarrollo de Staphylococcus aureus con el siguiente antibiograma: ¿Cuál de los siguientes antibióticos es de elección para el manejo inicial?

A) Flucloxacilina
B) Cefazolina
C) Vancomicina
D) Tetraciclina
E) Cotrimoxazol

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tratamiento de Staphylococcus aureus Resistente a la Meticilina: Un antibiograma que muestra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), siendo resistente a los betalactámicos en general, incluyendo oxacilina y cefalosporinas. El tratamiento de elección para el SARM es la vancomicina.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 161 1.04.1.021 · Osteomielitis

Un paciente de 60 años, diabético, consulta por dolor lumbar intenso, de 5 días de evolución, asociado a malestar general y fiebre hasta 38,9°C. Al examinarlo, presenta marcado dolor al presionar la zona vertebral lumbar, con una contractura de la musculatura paravertebral. El diagnóstico más probable es:

A) Espondilitis anquilosante
B) Aplastamiento vertebral
C) Lumbago mecánico
D) Lumbociática
E) Discitis lumbar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Discitis lumbar** (opción **E**). Las miopatías por estatinas son el efecto adverso más frecuente y clínicamente relevante de estos fármacos, afectando al 5-10% de los usuarios. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 172 1.04.2.005 · Infección invasiva de part

Un paciente de 53 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en la pierna derecha, desde hace 2 días, que se ha extendido hasta alcanzar un gran tamaño y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg. Además, se aprecia la lesión eritematosa de 20 cm, con zonas violáceas y bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

A) Erisipela
B) Herpes zóster
C) Pioderma gangrenoso
D) Fasceítis necrotizante
E) Celulitis bacteriana

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la parte iniciar del cuadro sugería una erisipela o celulitis (se diferencias fácilmente por los bordes nítidos o difusos, respectivamente), la presencia de zonas violáceas y bulas es sugerente de fasceítis necrotizante (la erisipela también puede tener pequeñas bulas). Lia...

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 135 1.04.2.005 · Infección invasiva de part

Un paciente de 48 años, diabético mal controlado, presenta una lesión en el muslo derecho, desde hace 5 días, que ha crecido y se ha asociado a malestar general y fiebre. Al examen físico tiene T°: 39,0°C, FC: 115x', PA: 90/60 mmHg y se aprecia la lesión de 20 cm de aspecto eritemato-violáceo, con bulas en su superficie. El diagnóstico más probable es:

A) Erisipela
B) Herpes zóster
C) Ántrax
D) Fasceítis necrotizante
E) Miositis necrotizante

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fasceítis necrotizante** (opción **D**). Es una fasceítis necrotizante clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 100 1.04.2.002 · Encefalitis aguda

Un paciente de 43 años, presenta un cuadro clínico de fiebre de 4 días de evolución, asociado a cefalea. Hoy se agrega desorientación y confusión, convulsionando en dos oportunidades antes de consultas. La TAC de cerebro muestra una zona hiperdensa en el lóbulo temporal izquierdo. Se realiza punción lumbar, con 130 células por mm3, 85% mononucleares, glucosa: 75 mg/dl (glicemia 90 mg/dl), proteínas 100 mg/dl, con Pandy (+), látex negativo y ausencia de bacterias en la tinción de Gram. Los cultivos están pendientes. El diagnóstico más probable es:

A) Meningitis bacteriana aguda
B) Meningitis tuberculosa
C) Meningoencefalitis herpética
D) Meningitis por enterovirus
E) Meningitis por VIH

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una meningoencefalitis herpética clásica, con la clínica de compromiso de conciencia (o convulsiones) y la clásica afectación de los lóbulos temporales. La punción sugiere infección viral (glucosa normal: sobre 40; y pleocitosis mononuclear), aunque le falta la presencia de glóbulos rojos, característica del herpes.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 147 1.04.1.018 · Malaria

Una paciente realiza un viaje a la selva amazónica y, al cuarto día luego de su regreso, presenta fiebre alta hasta 39,3°C, asociada a cefalea intensa y persistente, con marcado malestar general y mialgias. Se realiza un hemograma, que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 g/dl, glóbulos blancos: 16.000 por mm3, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 93.000 por mm3 y VHS: 35 mmHg. El agente etiológico más probable es:

A) Viruz zika
B) Virus dengue
C) Plasmodium falciparum
D) Salmonella typhi
E) Virus de fiebre amarilla

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy difícil, en especial porque es muy infrecuente la malaria por P. falciparum en América, incluyendo la Amazonía. Sin embargo, la presencia de anemia marcada hace que el diagnóstico sea malaria y no las demás opciones. La clínica es compatible también con el dengue. El virus Zika puede tener la misma clínica, pero suele ser menos intensa; a la fiebre amarilla le falta la ictericia; a la fiebre tifoidea le falta la diarrea.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 149 1.04.4.015 · Reacción de polimerasa en

Un paciente de 35 años, en situación de calle, presenta un cuadro de 6 meses de evolución de tos con expectoración mucosa y mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica, asociada a malestar general, disnea de esfuerzos, baja de peso y sensación febril. Al examen físico, está enflaquecido, pálido, con T°: 37,5°C, FC: 87x', PA: 110/70 mmHg, FR: 18x'. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales y algunas sibilancias. Su hemograma muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, leucocitos: 15.600 por mm3, VHS: 60 mm/h, PCR: 120 mg/L y elisa VIH negativo, PCR covid-19 negativa, baciloscopías de expectoración negativas, con muestra hemorrágica y PPD: 20mm. Se realiza una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente radiopaedia): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar TAC de tórax
B) Solicitar cultivo para bacillus tuberculosis en medio sólido
C) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
D) Repetir la PCR de covid-19 en muestra nasofaríngea
E) Realizar fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Nuevamente, tiene clínica de tuberculosis. Si bien las baciloscopías siguen siendo un excelente examen, su sensibilidad con 3 muestras ronda el 80%, siendo menor aún en muestras hemoptoicas, por lo que se prefiere realizar pruebas más sensibles, como la PCR para TBC, que incluso actualmente se recomienda como examen inicial. El cultivo de Koch también sirve, pero demora 2 a 4 semanas en tener un resultado.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 26 1.04.4.015 · Reacción de polimerasa en

Un paciente de 39 años, VIH positivo, que abandonó el tratamiento antiviral hace varios meses, consulta por un cuadro de tos de 2 meses de evolución, asociado a expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica, más sensación febril y baja de peso de 3 kilogramos. Al examen físico, se aprecia enflaquecido, con FC: 100x', PA: 110/60 mmHg, FR: 22x', saturación de oxígeno: 93%, T°: 37,5°C y, en el examen pulmonar, se auscultan crepitaciones y estertores bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que se muestra zonas de relleno bilaterales y se solicitan baciloscopías de expectoración que resultan negativas, con muestra hemorrágica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar TAC de tórax
B) Realizar lavado bronquioalveolear
C) Realizar broncoscopía
D) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
E) Iniciar tratamiento con ceftriaxona endovenosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene clínica de tuberculosis. Si bien las baciloscopías siguen siendo un excelente examen, su sensibilidad con 3 muestras ronda el 80%, siendo menor aún en muestras hemoptoicas, por lo que se prefiere realizar pruebas más sensibles, como la PCR para TBC, que incluso actualmente se recomienda como examen inicial.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 132 1.04.4.015 · Reacción de polimerasa en

Una paciente de 48 años, VIH posi8vo, que abandonó el tratamiento an8rretroviral hace 2 años, consulta por un cuadro clínico de dos semanas de evolución de tos con expectoración mucopurulenta que ha ido en aumento y fiebre hasta 38,1 °C. Al examen Fsico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 22 x', saturación arterial de oxígeno 91%, frecuencia cardíaca de 100 x' y presión arterial de 100/70 mmHg. El examen pulmonar se auscultan estertores, crépitos y roncus, mayores en el campo pulmonar superior derecho. Se solicita radiograFa de tórax que se muestra a con8nuación: ¿Qué examen es más adecuado para con8nuar el estudio?

A) Reacción en cadena de polimerasa para Pneumocys8s jirovecii en expectoración
B) Fibrobroncoscopía
C) Tinción de Gram y cul2vo de expectoración
D) Tomogra:a axial computada de tórax
E) Reacción en cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis en expectoración

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien los pacientes VIH deben estudiarse de forma amplia, en búsqueda de muchos patógenos (con cobertura antibiótica de amplio espectro mientras), en este caso el cuadro clínico sugiere fuertemente una tuberculosis, especialmente por el compromiso clínico y radiológico de los lóbulos superiores. Fuente imagen: Radiopaedia.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 18 · 1.04.4.017 · Urocultivo y antibiograma

Un hombre de 94 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, postrado e institucionalizado, es usuario de sonda Foley a permanencia, debido a obstrucción urinaria de causa prostática. Se cambia la sonda cada 30 días, habiéndose realizado el último cambio hace 15 días. Se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli multisensible. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cambiar la sonda y solicitar urocultivo de control
B) Iniciar ceftriaxona endovenosa
C) Iniciar ciprofloxacino oral
D) Iniciar cotrimoxazol oral
E) Mantener los cuidados habituales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Cambiar la sonda y solicitar urocultivo de control** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 45 · 1.04.1.026 · Toxicoinfección alimentari

Paciente adulto con dolor abdominal, diarrea + fiebre x campylobacter, ¿cual es el tratamiento?: a. Azitromicina

B) Hidratacion + probioticos
C) Ciprofloxacino
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **** (opción **A**). Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 55 · 1.04.1.026 · Toxicoinfección alimentari

Un paciente de 14 años, sin antecedentes de importancia, presenta diarrea desde hace 7 días, asociadas a malestar general y fiebre. Se solicitan exámenes de deposiciones, entre los que destaca DNA Microarray positivo para Campylobacter jejuni. ¿Cuál es la tratamiento más adecuado?

A) Cotrimoxazol
B) Metronidazol
C) Azitromicina
D) Ciprofloxacino
E) Probióticos

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Probióticos** (opción **E**). Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 76 · 1.04.1.026 · Toxicoinfección alimentari

Paciente con diarrea disentérica aguda y panel gastrointestinal positivo para Campylobacter. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Ciprofloxacino oral por 3 días
B) Metronidazol oral por 7 días
C) Cotrimoxazol oral por 5 días
D) Amoxicilina oral por 7 días
E) Azitromicina vía oral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Azitromicina vía oral** (opción **E**). Azitromicina vía oral. Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 6 · 1.04.1.004 · Brucelosis

Veterinario expuesto a ganado, dolor articular. Artrocentesis con PMN 70% a. brucelosis b. Fiebre Q

C) Cultivo de gonococo
D) Hemocultivo
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). Existen varios tipos de insulina que hay que conocer. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Cultivo de gonococo, Hemocultivo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 57 · 1.04.3.006 · Prevención de infecciones

Un lactante de 12 meses, VIH positivo, con cargas virales detectables, en tratamiento antirretroviral acude a control. ¿Qué vacuna está contraindicada en este paciente?

A) Anti meningocócica conjugada
B) Anti neumocócica conjugada
C) Anti influenza
D) Tres vírica
E) Anti SARS CoV2

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Vacunación con microorganismos vivos atenuados en pacientes inmunodeprimidos: Las inmunodeficiencias y otras causas de inmunodepresión generalmente contraindican la vacunación con microorganismos vivos atenuados, como la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola). Sin embargo, en el caso de pacientes con VIH, la vacuna triple vírica se puede administrar si tienen un nivel de inmunidad aceptable. El nivel de inmunidad se evalúa mediante el recuento de linfocitos CD4 positivos. La carga viral del VIH también puede proporcionar información sobre el grado de inmunodepresión, pero es un indicador menos confiable.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 56 1.04.1.027 · Triquinosis

Un paciente de 25 años que vive en una zona rural consulta por cefalea y mialgias intensas de 7 días de evolución, asociadas a malestar general y sensación febril. Al examen Fsico presenta temperatura: 37,5 °C, frecuencia cardíaca: 115 por minuto y presión arterial: 100/60 mmHg. Se solicitan exámenes que muestran PCR 5,6 mg/L (valor normal: menor a 0,5 mg/dl), hemograma con 15.000 glóbulos blancos/mm³, 290.000 plaquetas/mm³ y hematocrito de 35%. En la fórmula diferencial de la serie blanca presenta 40% de eosinófilos. Se solicitan CK, que resultan 2.500 U/L (VN: 30-170 U/L). El estudio ecocardiográfico es compa8ble con miocardi8s aguda. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Fasciolasis hepá2ca
B) Neurosis2cercosis
C) Hida2dosis
D) Infección por Trichinella spiralis
E) Infección por virus Coxsackie

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una triquinosis clásica: mialgias + eosinofilia + CK elevadas. Puede afectar el corazón y otros órganos. Se trata con analgésicos más albendazol o mebendazol. Si hay signos de gravedad (ej. miocardiGs de este caso), se agregan corticoides.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 57 1.04.1.012 · Fiebre tifoídea y paratifo

Un niño de 7 años presenta fiebre persistente desde hace 7 días, mayor en la tarde, hasta 38,9 °C, asociada a cefalea, anorexia y dolor abdominal. Al examen Fsico 8ene temperatura: 38,2 °C, frecuencia cardíaca: 62x' y frecuencia respiratoria: 15x'. Se palpa abdomen sensible de manera difusa, sin signos peritoneales. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 35%, glóbulos blancos: 3.700/mm³ con 70% segmentados, 9% cayados, 16% linfocitos, 5% monocitos, 0% eosinófilos y VHS 65 mm/h. Su proteína C reac8va resulta 6,9 mg/L (valor normal: < 0,5 mg/L). ¿Cuál es el agente e8ológico más probable?

A) Brucella melitensis
B) Salmonella typhi
C) Escherichia coli enterotoxigénica
D) Virus de Epstein-Barr
E) Citomegalovirus

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Aunque el cuadro clínico es algo inespecífico, el hemograma con leucopenia, algo de desviación izquierda y aeosinofilia es el clásico "hemograma Vfico".

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 7 1.04.2.008 · Síndrome pulmonar por Hant

Paciente de 28 años llega a urgencias con fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, compromiso respiratorio progresivo y antecedente de trabajo en zona rural del sur de Chile. Hemograma con leucopenia y trombocitopenia. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Hantavirus (Sin Nombre)
B) Leptospira interrogans
C) Rickettsia conorii
D) Yersinia pestis
E) Francisella tularensis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hantavirus pulmonar en Chile es transmitido por ratón colilargo. Fase cardiopulmonar: edema pulmonar no cardiogénico + leucopenia + trombocitopenia. Es la causa más probable en zona rural del sur.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 135 1.04.4.008 · Gram

En el examen microscópico de una muestra de esputo se observan cocos gram positivos agrupados en racimos. ¿A qué bacteria corresponde este patrón morfológico?

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Enterococcus faecalis
D) Listeria monocytogenes
E) Neisseria meningitidis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Cocos gram positivos en racimos (como uvas) = Staphylococcus spp. Los estreptococos forman cadenas, los enterococos pares o cortas cadenas, y Neisseria son gram negativos en diplococo.

GASTROENTEROLOGÍA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 03

181 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

42 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.06.1.001	Ascitis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 03 · C.4 (Pág. 12)
1.06.1.002	Cáncer de páncreas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 03 · C.2 (Pág. 8)
1.06.1.003	Cáncer de vesícula y vías biliares	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 03 · C.3 (Pág. 10)
1.06.1.004	Cáncer gástrico	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 03 · 1.5 (Pág. 13)
1.06.1.006	Colelitiasis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 03 · 4.1 (Pág. 46)
1.06.1.007	Colestasia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	10 Q	Tomo 03 · 3.1 (Pág. 35)
1.06.1.008	Trastornos digestivos funcionales	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 03 · 2.1 (Pág. 20)
1.06.1.009	Constipación	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 03 · C.8 (Pág. 20)
1.06.1.010	Diarrea asociada a antibióticos	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 03 · C.9 (Pág. 22)
1.06.1.011	Diarrea crónica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · C.10 (Pág. 24)
1.06.1.013	Disfagia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 03 · 1.3 (Pág. 9)
1.06.1.014	Dispepsia	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.015	Enfermedad celiaca	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	7 Q	Tomo 03 · 2.3 (Pág. 24)
1.06.1.016	Enfermedad diverticular complicada	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.018	Enfermedad inflamatoria intestinal	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	21 Q	Tomo 03 · 2.4 (Pág. 26)
1.06.1.019	Hepatitis aguda A no complicada	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 03 · 3.2 (Pág. 37)
1.06.1.020	Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.021	Hepatitis crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.024	Masa hepática	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 03 · 3.4 (Pág. 41)
1.06.1.025	Pancreatitis crónica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.1.027	Reflujo gastroesofágico	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	8 Q	Tomo 03 · 1.1 (Pág. 5)
1.06.1.028	Síndrome de malabsorción	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.06.1.029	Tumores de colon	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	10 Q	Tomo 03 · 2.5 (Pág. 28)
1.06.1.030	Úlcera péptica	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	8 Q	Tomo 03 · 1.2 (Pág. 7)
1.06.2.001	Abdomen agudo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · 5.1 (Pág. 53)
1.06.2.002	Afagia aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · 1.4 (Pág. 11)
1.06.2.003	Colangitis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.005	Diarrea aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 03 · 2.2 (Pág. 22)
1.06.2.006	Encefalopatía hepática	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.007	Hemorragia digestiva alta y baja	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 03 · 5.3 (Pág. 57)
1.06.2.008	Hepatitis aguda A complicada	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.2.010	Pancreatitis aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 03 · 4.2 (Pág. 48)
1.06.2.011	Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	8 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.3.005	Antiinflamatorios no esteroidales y tracto gastrontestinal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.3.006	Esteatopatía no alcohólica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.4.005	TAC abdominal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.4.006	Ecotomografía abdominal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.4.007	Endoscopía digestiva alta y baja	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.4.010	Estudio de perfil hepático	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.4.012	Estudio de marcadores virales para hepatitis A, B y C	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.4.014	Determinación toxina C difficile en deposiciones	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)
1.06.4.015	Colangiografía por resonancia magnética	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 03 · Gastroenterología (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 34 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Un paciente se realiza una colonoscopía, para la resección de unos pólipos intestinales. Algunas horas después presenta dolor abdominal bajo, asociado a hematoquezia escasa y malestar general. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

A) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
B) Ecografía abdominal y pélvica
C) Colonoscopía
D) Radiografía de abdomen y pelvis
E) TAC de abdomen y pelvis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una diverticulitis aguda post colonoscopía. Se estudia con TAC. Está absolutamente contraindicada la colonoscopía

---

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 110 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 24 horas de evolución, mayor en la fosa ilíaca izquierda, que se ha asociado a tres episodios de diarrea acuosa sin sangre. Al examen Fsico, sus signos vitales muestran presión arterial 132/85 mmHg, frecuencia cardíaca 85 por minuto y temperatura 37,5 °C. En la exploración abdominal presenta dolor a la palpación abdominal, especialmente intenso en la fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Gastroenteri2s aguda
B) Diver2culi2s aguda
C) Apendici2s aguda
D) Endometri2s aguda
E) Coli2s isquémica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una diverGculiGs aguda clásica. Se estudia con TAC. El manejo depende de la clasificación de Hinchey: - Ia (flegmón/inflamación pericólica): antibióticos VO. - Ib (absceso pericólico < 5 cm): antibióticos VO o EV. - II (absceso distante o > 5 cm): drenaje x punción + antibióticos EV. - III (peritoniGs purulenta generalizada): cirugía (ej. Hartmann). - IV (peritoniGs fecaloidea): cirugía (Hartmann).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 169 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Un paciente de 68 años consulta por dolor abdominal bajo, asociado a fiebre, que es mayor en el cuadrante inferior izquierdo. Al examen físico tiene T°: 37,7°C, FC: 94x', PA: 110/76 mmHg y su examen abdominal muestra abdomen doloroso a la palpación, con marcada resistencia muscular en la fosa iliaca izquierda y disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

A) Diverticulitis aguda
B) Colitis isquémica
C) Apendicitis aguda
D) Vólvulo de sigmoides
E) Cáncer de colon complicado

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una diverticulitis clásica: dolor en la FII, con signos peritoneales (resistencia muscular y RHA disminuidos).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 57 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con metformina, glibenclamida y enalapril, consulta por dolor abdominal, de 2 días evolución, mayor en el flanco izquierdo y en la fosa iliaca izquierda, asociado a sensación febril. Al examen físico presenta T°: 38°C, PA: 100/60 mmHg, FC: 88x', abdomen doloroso a la palpación, mayor en la zona, con signos peritoneales localizados en dicha área y disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto del ciego
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Colitis isquémica
D) Obstrucción intestinal
E) Diverticulitis aguda

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Diverticulitis aguda** (opción **E**). Es una diverticulitis clásica.. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 91 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Una paciente de 60 años presenta dolor abdominal de 2 días de evolución, mayor en el abdomen bajo. Al examen físico tiene dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad inflamatoria pélvica
B) Diverticulitis aguda
C) Colitis isquémica
D) Apendicitis aguda
E) Enfermedad de Cröhn

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Diverticulitis aguda** (opción **B**). Es una diverticulitis aguda clásica.. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 19 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes e hipertensión, en tratamiento con metformina, glibenclamida y enalapril, consulta por dolor abdominal, de 24 horas de evolución, localizado en el hipogastrio y la fosa iliaca izquierda, asociado a sensación malestar general. Al examen físico presenta T°: 37,8°C, PA: 100/60 mmHg, FC: 88x', abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda, mayor en la zona descrita, con signos peritoneales localizados en dicha área y disminución de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto epiploico apendicular
B) Embolia mesentérica
C) Vólvulo de sigmoides
D) Obstrucción intestinal
E) Diverticulitis aguda

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Diverticulitis aguda** (opción **E**). El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 157 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Mujer de 88 años de edad, quien presenta clínica un día de evolución caracterizada por fiebre, diarrea y dolor en hipogastrio. Refiere evacuaciones sin otras alteraciones. Al examen físico presenta temperatura en 38,5 grados, presión arterial de 90/50 mmHg y al examen abdominal presenta dolor y sensibilidad a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

A) Diverticulitis aguda
B) Colitis isquémica
C) Pielonefritis aguda
D) Enfermedad inflamatoria intestinal
E) Rectocolitis bacteriana

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una diverticulitis aguda clásica, aunque aún no tenga signos peritoneales. El dolor en la FII y la fiebre lo sugieren fuertemente. Por el buen estado general, seguro es Hinchey I.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 171 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Una paciente de 70 años, al tercer día después de una colonoscopía, con resección de un pólipo, acude al servicio de urgencia por dolor abdominal muy intenso, en la zona inferior izquierda, asociada a sensación febril y deposiciones con sangre, en una oportunidad. Al examen físico tiene abdomen doloroso a la palpación profunda, mayor en la fosa ilíaca izquierda y signo de Blumberg en dicha zona. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

A) Radiografía de abdomen simple
B) Ecotomografía abdominal
C) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
D) Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
E) Colonoscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es otra diverticulitis, que, aunque su diagnóstico es clínico, se estudia con TAC de abdomen y pelvis, de modo de definir el manejo (buscar abscesos y líquido libre). Recordemos que el tratamiento de la diverticulitis depende de la clasificación de Hinchey; Tipo I (solo edema o abscesos pericólicos menores a 5 cm): ATB orales; tipo II (absceso mayor a 5 cm o a distancia): ATB ev y drenaje por punción; tipo III (peritonitis difusa) y tipo IV (peritonitis estercorácea): cirugía de Hartmann. Si bien la colonoscopía sirve para el diagnóstico de la enfermedad diverticular no complicada y la para la HDB de origen diverticular, está absolutamente contraindicada en la diverticulitis aguda.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 130 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Una paciente de 70 años acude por cuadro clínico de doce horas de evolución caracterizada por dolor en hemiabdomen inferior, que ha ido en aumento, siendo mayor en el hemiabdomen izquierdo. Al examen físico, presenta frecuencia cardíaca de 96 lpm, PA: 90/60 mmHg, temperatura 38,5 grados, sudoración y palidez, y examen abdominal con abdomen doloroso a la palpación, con Blumberg (+) y signos de irritación peritoneal en la fosa iliaca izquierda. El diagnóstico más probable es:

A) Diverticulitis aguda
B) Cáncer colorectal complicado
C) Vólvulo sigmoideo
D) Obstrucción intestinal
E) Cáncer de ovario complicado

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Diverticulitis aguda** (opción **A**). Es una diverticulitis clásica, con irritación peritoneal en la FII (fosa iliaca izquierda).. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 2 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Una paciente de 65 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina, consulta por cuadro de dolor en fosa iliaca izquierda, asociado a fiebre y hematoquezia en una oportunidad. Al examen físico destaca Blumberg (+) en fosa iliaca izquierda y disminución de ruidos hidroaéreos. El examen de elección para establecer el diagnóstico en este caso es:

A) Tomografía axial computada de abdomen
B) Colonoscopía
C) Ecotomografía abdominal
D) Radiografía de abdomen
E) Resonancia magnética de abdomen

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Tomografía axial computada de abdomen** (opción **A**). Es una diverticulitis. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 144 1.06.1.016 · Enfermedad diverticular co

Una paciente de 77 años, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, consulta por un cuadro de 48 horas de dolor abdominal, mayor en el lado izquierdo, asociado a náuseas y deposiciones líquidas. Al examen Fsico presenta frecuencia cardíaca de 80 la8dos por minuto, regular, presión arterial de 140/94 mmHg y exploración abdominal con abdomen blando, doloroso a la palpación, mayor en el lado izquierdo. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Diver2culi2s aguda
B) Coli2s isquémica
C) Embolia mesentérica
D) Obstrucción intes2nal
E) Gastroenteri2s aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil, ya que tanto la diverGculiGs como la coliGs isquémica son compaGbles con el cuadro descrito. Si hubiese tenido hematoquecia, sin duda sería coliGs isquémica. En el caso concreto, los factores de riesgo cardiovascular, las deposiciones líquidas y el dolor en todo el lado izquierdo sugieren más una coliGs isquémica, por lo que la dejaremos como respuesta correcta, aunque sea menos frecuente que la diverGculiGs.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 12 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Paciente de 27 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 meses de dolor epigástrico tipo urente que aumenta durante los periodos de ayuno y estrés, asociado ocasionalmente a pirosis. Se realiza endoscopía digestiva alta que objetiva úlcera duodenal activa y se realiza test de ureasa que resulta (-). La conducta más adecuada en este caso es:

A) Iniciar omeprazol, amoxicilina y claritromicina
B) Indicar omeprazol y controlar con nueva endoscopía en 6 semanas
C) Solicitar nueva endoscopía digestiva alta con test de ureasa
D) Iniciar omeprazol, bismuto y metronidazol
E) Iniciar medidas anti reflujo y omeprazol a permanencia.

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una úlcera duodenal Activa. Aunque el test de ureasa esté negativo, si no usa AINES, se asume que es por H. pylori, porque el 90% de las úlceras duodenales son por esa causa y el test de ureasa no es un examen tan bueno. Es una pregunta difícil. En el caso de la úlcera gástrica, es más probable que pueda ser por otra causa (solo 70% es por HP) y se tendría que estudiar. También se estudiaría si hubiese algo más que hiciera sospechar otra enfermedad, como un Cröhn o un Zollinger Ellison.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 129 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Un hombre de 42 años consulta por dolor abdominal intenso de localización epigástrica, que inició hace 5 días después de haber consumido abundantes alimentos picantes. El dolor ha tenido un curso fluctuante, se ha asociado a náuseas y empeora con el ayuno, así como también después de haber u8lizado an8inflamatorios como analgésicos. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 85 por minuto y presión arterial 130/82 mmHg. Su examen cardiopulmonar es normal y el examen abdominal muestra dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales, masas ni visceromegalia. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Gastri2s erosiva
B) Úlcera pép2ca
C) Reflujo gastroesofágico
D) Pancrea22s aguda leve
E) Colecis22s aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un síndrome ulceroso (dolor epigástrico urente, que aumenta con el ayuno). La relación con AINEs y picante, también es sugerente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 163 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Una paciente de 40 años, con antecedente de artritis reumatoide, tratada con naproxeno oral, presenta un episodio de hemorragia digestiva alta, con melena. Se realiza una endoscopía digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal activa; no se realizó el test de ureasa. La conducta más adecuada es:

A) Cambiar el naproxeno por otro AINE
B) Solicitar serología para Helicobacter pylori
C) Solicitar nueva endoscopía con test de ureasa
D) Realizar erradicación de Helicobacter pylori
E) Iniciar inhibidores de la bomba de protones

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las úlceras gástricas se erradican solo si tienen HP positivo (a menos que no haya consumo de AINEs y exista algo que genere falsos positivos, como el uso de antibióticos o de omeprazol) y se controlan con una EDA, de modo de descartar que haya un cáncer debajo. Las úlceras duodenales (este caso) se erradican siempre, ya sea con HP positivo o negativo y se controlan con pruebas no invasivas, como la detección de antígenos en heces. Por ello, la respuesta es erradicar.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 124 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, con test de ureasa positiva, por lo que se inicia tratamiento con amoxicilina 1g cada 12 horas, claritromicina 500mg cada 12 horas y omeprazol 20mg cada 12 horas, por 10 días. Luego queda con omeprazol por 4 semanas más. Se controla posteriormente con antígeno de H. pylori en heces, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el tratamiento, pero por 14 días
B) Realizar endoscopía digestiva alta y biopsia
C) Indicar tratamiento erradicador de segunda línea
D) Realizar test de ureasa
E) Observar evolución

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la recomendación del Minsal es 14 días de tratamiento, hay suficiente evidencia que dicen que los tratamientos de 7 a 10 días son buenos. Si falla la erradicación, se debe dejar tratamiento erradicador de segunda línea. Otro problema con esta pregunta es que solo la úlcera duodenal se controla con antígeno en heces, mientras que la ulcera gástrica debería controlarse con EDA y biosia, para observar la curación de la úlcera y biopsiar el lecho (descartar cáncer). La pregunta es muy antipática (quien la redactó)

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 71 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Paciente con antecedente de úlcera gastroduodenal y anemia ferropénica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar hierro oral y controlar hemograma
B) Solicitar estudio de deposiciones para sangre oculta
C) Biopsias gástricas y test de ureasa
D) Erradicar H. pylori empíricamente
E) Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar endoscopía digestiva alta** (opción **E**). Solicitar endoscopía digestiva alta. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 15 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Un paciente masculino, de 34 años, consulta por dolor abdominal epigástrico, de dos meses de evolución, mayor postprandial y que cede con antiácidos. En el último tiempo se agregan vómitos postprandiales. Hace pocos días presentó un episodio de dolor nocturno, de moderada intensidad. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) pH esofágico de 24 horas
C) Radiografías baritadas de esófago, estómago y duodeno
D) Endoscopía digestiva alta
E) TAC de abdomen y pelvis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se sospecha una úlcera gastroduodenal (aunque el dolor suele ser más intenso en ayunas). Se estudia con EDA.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 70 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Un paciente de 36 años se hace una endoscopía digestiva alta, que muestra test de ureasa positiva para Helicobacter pylori. Como antecedente, tuvo una hemorragia digestiva alta hace 2 años, por una úlcera duodenal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la endoscopía digestiva alta
B) Erradicar Helicobacter pylori
C) Solicitar el test del aliento con úrea-C14
D) Iniciar antihistamínicos H2
E) Indicar omeprazol por 6 meses

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se erradican los pacientes con antecedente de úlcera y los con factores de riesgo para úlcera (uso de AINEs, dispepsia) y cáncer (displasia, metaplasia, antecedentes familiares marcados).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 70 1.06.1.030 · Úlcera péptica

Paciente con artritis reumatoide en tratamiento con AINEs, presenta melena. ¿Diagnóstico más probable?

A) Cáncer gástrico
B) Úlcera gastroduodenal
C) Angiodisplasia gástrica
D) Esofagitis erosiva
E) Síndrome de Mallory-Weiss

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Úlcera gastroduodenal** (opción **B**). Úlcera gastroduodenal. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 22 1.06.1.013 · Disfagia

Paciente de 80 años, con antecedente de hipertensión, diabetes insulinodependiente con mal control metabólico y epigastralgia en tratamiento crónico con omeprazol, consulta por cuadro de disfagia lógica asociado a odinofagia de un mes de evolución. Al examen físico no se encuentran alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer esofágico
B) Reflujo gastroesofágico
C) Acalasia
D) Candidiasis esofágica
E) Divertículo esofágico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por la disfagia lógica y por el antecedente de probable RGE (usa omeprazol). La acalasia produce disfagia ilógica. La edad sugiere también cáncer.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 112 1.06.1.013 · Disfagia

Un paciente de 80 años consulta por dificultades para comer, caracterizada por disfagia alta intermitente, tanto para alimentos sólidos como líquidos. Refiere, además, regurgitación frecuente de alimentos, halitosis y una pérdida de peso de 4 kg en los últimos meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acalasia esofágica
B) Cáncer de esófago
C) Divertículo de Zenker
D) Esclerosis sistémica con compromiso esofágico
E) Reflujo gastroesofágico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Divertículo de Zenker: El paciente presenta un cuadro clínico característico de un divertículo de Zenker, un tipo de divertículo esofágico. La halitosis y la disfagia alta, que suele ser intermitente y varía según el grado de represión del divertículo, son características de esta patología.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 43 1.06.1.013 · Disfagia

Un paciente de 70 años consulta por dificultad para tragar de 2 años de evolución, que se presenta tanto al ingerir alimentos sólidos como líquidos. Además, presenta pirosis y regurgitación frecuente postprandial. Ha bajado un total de 20 kilogramos desde el inicio de sus síntomas y su IMC actual es de 22,2. Al examen físico, tiene un abdomen excavado, sin palpación de masas, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos peritoneales. El resto de su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome pilórico
B) Acalasia esofágica
C) Esclerodermia sistémica
D) Cáncer gástrico
E) Divertículo esofágico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Disfagia en Adulto Mayor: Aunque la disfagia en un adulto mayor puede indicar cáncer de esófago, en este caso se observa una disfagia ilógica que afecta tanto a sólidos como a líquidos. La radiografía muestra la imagen clásica de acalasia esofágica con obstrucción distal y sin irregularidades en la pared del esófago, a diferencia del cáncer.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 38 1.06.1.013 · Disfagia

Una paciente de 56 años, con antecedente de haber vivido en Brasil, hasta hace 6 meses, consulta por disfagia lógica y progresiva, asociada a baja de peso de 6 kilogramos. Su examen físico no tiene alteraciones. Tiene antecedente de pirosis y regurgitación de larga data.

A) Cáncer de esófago
B) Estenosis péptica
C) Esofagitis eosinofílica
D) Acalasia esofágica
E) Cáncer gástrico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El antecedente de haber vivido en Brasil sugiere Chagas, sin embargo, la clínica es muy sugerente de cáncer de esófago, ya que tiene una disfagia lógica (afecta más la deglución de los sólidos grandes, luego los más pequeños y solo al final los líquidos). En cambio, Chagas, esclerodermia y acalasia suelen tener disfagia ilógica.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 145 1.06.1.013 · Disfagia

Una mujer de 30 años consulta por disfagia ilógica intermitente, asociada a pirosis, regurgitación de alimentos y en ocasiones, dolor retroesternal. Es usuaria de omeprazol, de manera intermitent

E) Su examen físico muestra signos vitales normales y el examen abdominal también es normal. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en esta paciente?
A) Manometría esofágica
B) Radiografías contrastadas de esófago, estómago y duodeno
C) Monitorización de pH esofágico de 24 horas
D) TAC de abdomen y pelvis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Manometría esofágica). Clase sobre disfagia (dificultad para tragar), diferenciando la disfagia lógica (progresiva, primero sólidos luego líquidos, obstrucción, típica del cáncer de esófago) de la ilógica (fluctuante, afecta líquidos desde el inicio, trastorno motor, típica de acalasia y esclerodermia). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 175 1.06.1.013 · Disfagia

Una paciente de 50 años presenta disfagia intermitente desde hace 4 meses y recientemente presentó un episodio de dolor torácico intenso, opresivo, que inició en relación a una discusión familiar. En el servicio de urgencias se solicita electrocardiograma, que muestra ritmo sinusal sin signos de isquemia y troponinas plasmá8cas seriadas que resultan nega8vas. Actualmente se encuentra asintomá8ca, sin alteraciones en su examen Fsico. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Radiogra:a de esófago, estómago y duodeno con doble contraste
B) Endoscopía diges2va alta
C) Manometría esofágica
D) Estudio de videodeglución
E) Cin2gra:a de perfusión miocárdica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La disfagia intermitente hace pensar en una acalasia esofágica u otro trastorno motor del esófago, que se estudia con manometría esofágica como examen de elección. Se asocia al espasmo esofágico, que parece ser la causa del dolor torácico actual (el espasmo se asocia a reflujo y acalasia y clínicamente responde muy bien a nitritos). De todos modos, en el manejo del paciente es fundamental descartar un síndrome coronario u otra patología grave que pueda provocar el dolor torácico y no confiarse, por lo que fue del todo correcto hospitalizarlo y solicitar ECG y troponinas seriadas, así como también darle aspirina, oxígeno y nitroglicerina y hacer un test de esfuerzo antes del alta.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 53 1.06.1.013 · Disfagia

Una paciente de 65 años consulta por disfagia ilógica, asociada a halitosis de reciente comienzo y regurgitación de alimentos recién ingeridos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis péptica del esófago distal
B) Divertículo de Zenker
C) Cáncer de esófago cervical
D) Cáncer de faringe
E) Acalasia esofágica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la disfagia ilógica es clásica de la acalasia (disfagia baja) y de la esclerodermia, también se puede ver en el divertículo de Zenker (disfagia alta), ya que puede estar más o menos lleno de alimentos. Eso sí, la halitosis orienta fuertemente a divertículo esofágico.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 22 1.06.1.013 · Disfagia

Un paciente de 71 años consulta por dificultad para tragar de 1 mes de evolución. Además presenta halitosis que antes no tenía, asociada a regurgitación de alimentos recién ingeridos

A) Estenosis péptica esofágica
B) Divertículo de Zenker
C) Cáncer de esófago
D) Cáncer de laringe
E) Acalasia esofágica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Divertículo de Zenker). Es un divertículo de Zenker clásico.. Clase sobre disfagia (dificultad para tragar), diferenciando la disfagia lógica (progresiva, primero sólidos luego líquidos, obstrucción, típica del cáncer de esófago) de la ilógica (fluctuante, afecta líquidos desde el inicio, trastorno motor, típica de acalasia y esclerodermia). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 150 1.06.1.013 · Disfagia

Hombre de 70 años desdentado con disfagia alta para sólidos de inicio súbito tras comer. Endoscopia: cuerpo extraño (trozo de carne) impactado en esófago superior. Ya se realizó endoscopia de extracción exitosa. ¿Cuál es el estudio de seguimiento más importante?

A) Nueva endoscopía para evaluar mucosa esofágica subyacente y descartar estenosis o tumor
B) Rx de tórax de control
C) TAC de cuello y tórax
D) Alta directa sin más estudio
E) Esofagografía con bario

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Impactación de alimento en esófago, especialmente en adulto mayor, debe hacer sospechar patología esofágica subyacente (estenosis péptica, anillo de Schatzki, tumor). Nueva endoscopía de evaluación es obligatoria.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 84 1.06.1.013 · Disfagia

Un paciente de 56 años, fumador de 10 paquetes-año, consulta por disfagia de 6 meses de evolución, que inicialmente afectaba solo la ingesta de sólidos, pero que actualmente se ha extendido también a la ingesta de líquidos. Al examen Fsico se aprecia enflaquecido, con signos vitales normales, sin palpación de masas ni otras alteraciones en el examen abdominal. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Acalasia esofágica
B) Cáncer gástrico
C) Diveraculo esofágico
D) Trastorno de la deglución
E) Cáncer esofágico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Su cuadro clínico es una disfagia lógica (primero sólidos y luego progresa), que es lo característico del cáncer de esófago avanzado.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 49 1.06.1.013 · Disfagia

Paciente masculino de 42 años, cursa desde hace 1 año con disfagia asociada a regurgitación ocasional de alimentos no digeridos, por lo que necesita tomar agua con las comidas, para poder tragar. Además refiere baja de peso en los últimos meses. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer esófago
B) Cáncer gástrico de cardias
C) Estenosis esofágica, secundaria a esofagitis por reflujo gastroesofágico
D) Acalasia esofágica
E) Esofagitis por Cándida albicans

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta algo capciosa, porque la clínica calza tanto con cáncer de esófago, como con cáncer gástrico cardial, ya que se trata de una disfagia lógica. Sin embargo, la correcta será cáncer de esófago, por ser la presentación clásica.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 97 1.06.2.003 · Colangitis

Una paciente de 52 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso, de localización epigástrica e irradiado a los flancos, que se asocia a vómitos y orinas oscuras. Además, ha presentado fiebre hasta 39°C y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de escleras, piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 110x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis múltiple en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar colecistectomía laparoscópica
B) Realizar colecistectomía abierta más coledocostomía
C) Solicitar colangioresonancia magnética nuclear
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una colangitis aguda clásica. Se trata con drenaje endoscópico de la vía biliar (además, se da SF ev, ATB ev y, en segunda instancia, se realiza una colecistectomía laparoscópica).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 145 1.06.2.003 · Colangitis

Una paciente de 70 años presenta dolor abdominal intenso de 24 horas de evolución, asociada a fiebre hasta 38,5°C, marcado malestar general y vómitos alimentarios, en múltiples ocasiones. Al examen físico tiene PA: 90/60 mmHg, FC: 105x', se aprecia ictericia de piel y mucosas y su abdomen es doloroso, de manera difusa, con resistencia muscular, mayor en el hemiabdomen superior. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina total: 6,8 mg/dl, Bilirrubina directa: 6,1 mg/dl, FA: 512 UI/L, GGT: 334 UI/L, GOT: 250 UI/L y GPT: 170 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Colecistitis enfisematosa
B) Plastrón vesicular
C) Hepatitis aguda
D) Colangitis aguda
E) Colédocolitiasis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene la triada de Charcot: dolor, ictericia y fiebre, más el compromiso hemodinámico clásico de la colangitis.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 101 1.06.2.003 · Colangitis

Una paciente de 70 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y sensación febril, de 6 horas de evolución, a lo que se ha agregado ictericia. Al examen físico pre- senta FC: 87x', PA. 90/60 mmHg, temperatura: 38,5 grados Celsius. Al examen abdominal tiene intenso dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diag- nóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Colangitis aguda
C) Pancreatitis aguda
D) Colecistitis aguda
E) Hepatitis aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene la triada de Charcot: fiebre, ictericia y dolor, más la hiptensión arterial. Es una colangitis clínica.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 96 1.06.2.003 · Colangitis

Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal de 12 horas de evolución, intenso y asociado a vómitos. Además ha presentado fiebre hasta 38,8 grados y aumento del dolor abdominal, en especial en el hemiabdomen superior. Al examen físico tiene ictericia de piel y mucosas, PA: 90/60 mmHg y FC: 116x'. Se realiza una ecografía abdominal que muestra colédoco de 11 mm de dilatación y litiasis en la vesícula biliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar colecistectomía laparoscópica
B) Realizar drenaje endoscópico de la vía biliar
C) Solicitar colangioresonancia magnética nuclear
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Realizar colecistectomía más coledocostomía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene criterios de colangitis aguda (dolor, fiebre, ictericia y compromiso hemodinámico), por lo que se debe proceder al drenaje por CPRE.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 23 1.06.2.003 · Colangitis

Una paciente de 50 años, con antecedente de colecistectomía hace varios años, presenta desde hace dos días cuadro de dolor epigástrico, ictericia fluctuante, orinas oscuras y fiebre. Al examen físico destaca frecuencia cardiaca de 100 por minuto, presión arterial de 80/50 mm de Hg, dolor a la palpación epigástrica, blumberg (+), ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita ecografía abdominal que muestra vía biliar de 10mm. La conducta más adecuada en esta paciente es:

A) Realizar colangioresonancia
B) Realizar tomografía axial computada de abdomen
C) Realizar laparotomía abierta
D) Indicar antibióticos de amplio espectro y reevaluar en 48 horas
E) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un diagnóstico de colangitis aguda clínica. Se debe hacer drenaje endoscópico de la vía biliar, lo que no aparece en las alternativas. De las opciones, la más aceptable es la CPRE (aunque en realidad lo que se hará es una papilotomía y drenaje). La presencia de Blumberg confunde, ya que podría indicarnos una Cirugía, pero el manejo de elección sigue siendo en drenaje endoscópico. De todos modos es probable que la pregunta original haya estado redactada de otra forma.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 152 1.06.2.003 · Colangitis

Paciente de 60 años con fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho (tríada de Charcot). Ecografía: vía biliar dilatada, cálculo en colédoco. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A) Colangitis aguda: ATB EV + CPRE urgente para drenaje biliar
B) Hepatitis aguda: manejo conservador
C) Colecistitis aguda: colecistectomía laparoscópica
D) Absceso hepático: drenaje percutáneo
E) Pancreatitis aguda: reposo y fluidos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tríada de Charcot (fiebre + ictericia + dolor en HD) + coledocolitiasis = colangitis aguda. Emergencia: ATB de amplio espectro + drenaje biliar endoscópico urgente (CPRE) para descompresión.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 68 1.06.2.003 · Colangitis

Paciente con dolor en HCD, fiebre, ictericia y coluria, con patrón colestásico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecografía abdominal
B) CPRE de urgencia
C) Colecistectomía laparoscópica inmediata
D) Colangiografía intraoperatoria
E) Antibióticos y drenaje percutáneo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar ecografía abdominal** (opción **A**). Solicitar ecografía abdominal. Bilirrubina >1.1 es alta; ictericia clínica aparece sobre 2.5-3 mg/dL De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 174 1.06.1.006 · Colelitiasis

Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta dolor intermitente en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org El diagnóstico más probable es:

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colangiocarcinoma
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una imagen clásica de cálculos biliares, con la sombra acústica característica de los cálculos. La clínica son cólicos biliares.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 36 1.06.1.006 · Colelitiasis

Un paciente presenta hace una semana dolor en el hipocondrio derecho, intenso, asociado a vómitos, que cede espontáneamente. Actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen es el más adecuado para estudiar a este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) Radiografía de abdomen
C) Amilasa / Lipasa
D) Colangioresonancia
E) TAC de abdomen

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Probablemente tiene una colelitiasis (clínica de cólico biliar). Se estudia con Eco. En agudo sí debió haberse pedido la amilasa/lipasa para descartar pancreatitis, pero ahora solo hay que descartar la colelitiasis.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 56 1.06.1.006 · Colelitiasis

Embarazada de 32 semanas con sx de cole. Eco pared engrosada con calculos y VB 9 o 10 cm. Conducta:

A) Analgesia hasta fin del embarazo
B) CPRE (PORQ ESTA NO PODRIA SER???)- SGY Porque no tenía clínica de colangitis, que sería la indicación de drenaje inmediato. Sino sólo sospecha de coledocolitiasis.
C) colecistectomía+CIO
D) colecistostomía
E) Colangioresonancia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Analgesia hasta fin del embarazo** (opción **A**). Tratamiento: soporte. El 90% revierte completamente. Diálisis de urgencia si síndrome urémico establecido. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 109 1.06.1.006 · Colelitiasis

Mujer de 45 años operada de colecistectomía hace 6 meses. Ahora con dolor cólico en hipocondrio derecho, ictericia leve y coledocolitiasis residual confirmada por ecografía. ¿Cuál es el manejo?

A) CPRE con esfinterotomía y extracción del cálculo
B) Reoperación para exploración de vía biliar
C) Tratamiento médico con ácido ursodesoxicólico
D) Observar y controlar en 3 meses
E) Litotricia extracorpórea

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Coledocolitiasis residual sintomática: primera línea = CPRE con esfinterotomía endoscópica y extracción del cálculo. Evita reoperación y tiene alta tasa de éxito (>90%).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 146 1.06.1.006 · Colelitiasis

Un paciente de 55 años consulta por dolor abdominal, de 3 días de evolución, mayor en el epigastrio, asociado a vómitos alimentarios. Su examen abdominal muestra dolor a la palpación del epigastrio e hipocondrio derecho. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra vía biliar de 8 mm, con múltiples cálculos en la vesícula, de pequeño tamaño. Se solicitan pruebas hepáticas con fosfatasas alcalinas: 520 UI/L, GGT: 612 UI/L, GOT: 102 UI/L y GPT: 87 UI/L, bilirrubinemia: 6,0 mg/dl, con fracción directa de 4,6 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Realizar colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
B) Indicar colangioresonancia
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
D) Resolver quirúrgicamente
E) Indicar tratamiento analgésico y antibiótico endovenoso

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una coledocolitiasis. Se debe estudiar inicialmente con una colangioresonancia y luego (si la colangioRMN ve los cálculos), se procede a la CPRE (también se hace la CPRE si tiene clínica de colangitis o si la eco ve los cálculos en el colédoco).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 165 1.06.1.006 · Colelitiasis

Un paciente de 50 años, en tratamiento con antimicóticos orales desde hace 3 se- manas, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de prurito, ictericia y acolia, sin dolor. En su examen físico se aprecia ictérico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un pa- trón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Colestasia farmacológica
C) Síndrome de Mirizzi
D) Esteatosis hepática
E) Colelitiasis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Dado que hay dilatación del colédoco (mayor a 7 mm), lo más probable es que sea una colédocolitiasis. Las colestasias farmacológicas suelen producirse a nivel hepático y no a nivel del colédoco.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 66 1.06.1.006 · Colelitiasis

Un paciente de 55 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico destacan escleras ictéricas, sensibilidad a la palpación epigástrica. Se realiza exámenes donde destaca leucocitos 13.000/mm3, PCR 50 mg/dL, GOT 120mg/dL, GPT 140mg/dL, bilirrubina 3mg/dL, fosfatasas alcalinas 400mg/dL, lipasa 100mg/dL. Ecografía abdominal con vía biliar extrahepática dilatada. El diagnóstico más probable es:

A) Colangitis aguda
B) Pancreatitis aguda
C) Colecistitis aguda
D) Coledocolitiasis
E) Hepatitis aguda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una colédocolitiasis. Llama la atención la elevación de los blancos y la PCR, pero la clínica no está tan mal, como para ser una colangitis. La lipasa está elevada, pero menor a 180, por lo que no parece una pancreatitis.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 93 1.06.1.006 · Colelitiasis

Un paciente de 38 años, obesa, en tratamiento con antifúngicos orales desde hace 2 meses por onicomicosis, consulta por un cuadro de 7 días de evolución de prurito, ictericia y acolia, sin dolor abdominal. En su examen físico se aprecia ictérico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un patrón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Colestasia farmacológica
C) Colangitis aguda
D) Colestasia por esteatosis hepática
E) Colelitiasis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Como tiene una vía biliar mayor a 7 mm, está dilatada y lo más probable es que sea una coledocolitiasis. Llama la atención que no tenga dolor, pero probablemente tiene una obstrucción incompleta. No tiene fiebre ni compromiso de conciencia ni hipotensión, como para pensar en colangitis aguda. La B y la D son raras y no dilatan la vía biliar. La colelitiasis no tiene ictericia, aunque en este caso el barro biliar sugiere que sí hay una colelitiasis de base, que produjo la colelitiasis.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 67 1.06.1.006 · Colelitiasis

Paciente con dolor en hipocondrio derecho y coluria, patrón colestásico y dolor a la palpación del hipocondrio. ¿Diagnóstico más probable?

A) Colecistitis aguda
B) Colangitis aguda (Charcot)
C) Coledocolitiasis aguda
D) Hepatitis alcohólica
E) Cólico biliar simple

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Coledocolitiasis aguda** (opción **C**). Coledocolitiasis aguda. El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una de las causas más importantes de insuficiencia renal aguda en niños de tipo renal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 160 1.06.1.014 · Dispepsia

Mujer de 74 años con epigastralgia de 3 semanas de evolución, sin irradiación, sin baja de peso. Antecedente de dispepsia tratada hace 10 años. AINES ocasionales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Endoscopía digestiva alta (EDA) para descartar lesión orgánica (criterios de alarma por edad >60 años)
B) Iniciar IBP y controlar en 4 semanas
C) Test de Helicobacter pylori no invasivo y tratar si positivo
D) Radiografía de abdomen
E) Ecografía abdominal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Dispepsia en >60 años = criterio de alarma por edad → EDA obligatoria para descartar cáncer gástrico, úlcera péptica u otras lesiones orgánicas. No se puede tratar empíricamente en este grupo etario.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 70 1.06.1.014 · Dispepsia

Paciente de 28 años, con cuadro de 2 meses de dolor epigástrico urente, que aumenta en ayuno y al beber café, asociado a pirosis y reflujo ocasional. Al examen físico no se aprecian alteraciones. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Iniciar omeprazol
B) Iniciar amoxicilina y claritromicina
C) Solicitar ecografía
D) Solicitar test de ureasa
E) Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Puede ser una úlcera u otra cosa, pero las epigastralgias se estudian con EDA. Que aumente con el café y con ayuno orienta a úlcera.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 93 1.06.1.024 · Masa hepática

Una paciente de 70 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática, sin hábito alcohólico actual, VHBsAg (-) y Anticuerpos anti-VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico. En su laboratorio destaca alfafetoproteína de 5,3 ng/ml (VN: 0-7 ng/ml) El diagnóstico más probable es:

A) Metastásis hepática
B) Adenoma hepático
C) Carcinoma hepatocelular
D) Quiste hepático
E) Hemangioma hepático

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un adenoma hepático, por el aspecto, el tamaño (sólido, hipoecogénico, aspecto homogéneo) y por la alfafetoproteína no elevada. La cirrosis aumenta el riesgo de adenomas y hepatocarcinomas. Metástasis: se ven hipoecogénicas, sólidas y múltiples. Hepatocarcinoma: se ve heterogéneo y más grande, sólido y además eleva la AFP. Quiste: se ve anecogénico, con refuerzo posterior. Hemangioma: se ve hiperecogénico, homogéneo.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 89 1.06.1.024 · Masa hepática

Paciente de 55 años, con antecedente de esteatohepatitis no alcohólica y obesidad, se realiza ecografía abdominal como parte de chequeo donde se aprecia lesión levemente hipoecogénica, redondeada, sin sombra acústica ni refuerzo posterior. El diagnóstico más probable es:

A) Hiperplasia nodular focal
B) Hepatocarcinoma
C) Adenoma
D) Hemangioma
E) Hidatidosis hepática

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por ser hipoecogénica. Quistes son anecogénicos y hemangioma son hiperecogénicos. Cálculos tienen sombra acústica y quístes simples e hidatídicos tiene refuerzo posterior.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 24 1.06.1.024 · Masa hepática

Un paciente con antecedente de daño hepático crónico, por consumo de alcohol, se realiza un TAC abdominal de control, que muestra un tumor sólido en el lóbulo hepático derecho, de 3 cm de diámetro, que es hipervascular en la fase arterial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulo de regeneración
B) Hepatocarcinoma
C) Hemangioma hepático
D) Hiperplasia nodular
E) Adenoma hepático

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La asociación a DHC es tanto de adenoma, como de hepatocarcinoma, pero la hipervascularización orienta a hepatocarcinoma. Sin embargo, esta es una pregunta de radiología, que excede las competencias que debe tener un médico general.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 44 1.06.1.024 · Masa hepática

Nódulo hepático sólido: Estudio con ecografía abdominal > con que continuar el estudio

A) TAC Trifasico
B) Biopsia
C) RNM
D) Eco
E) Hemograma y VHS

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (TAC Trifasico). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Biopsia, RNM) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 92 1.06.1.024 · Masa hepática

Un paciente de 62 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo dos y de daño he- pático crónico secundario a una esteatohepatitis no alcohólica, ha presentado hospitali- zaciones por cuadros de hemorragia digestiva alta en el último año, actualmente con- trolado. Se realizan exámenes de control en que se demuestra fosfatasas alcalinas de 565 UI/L, GOT: 186 UI/L GPT: 172 UI7L, bilirrubina total 4,2mg/dL, alfafetoproteina: 119 ng/mL. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

A) Endoscopía digestiva alta
B) Ecografía abdominal
C) TAC abdominal
D) Gammaglutamil transferasa
E) Colangioresonancia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es un cáncer hepático, dada la alfafetoproteína de 119. Se inicia el es- tudio con una Ecografía.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 84 1.06.1.024 · Masa hepática

3) Una paciente de 72 años de edad, con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace 5 años acude a control médico. Trae VHBsAg (-) y Anticuerpos anti- VHC (-), Child Pugh clase A, MELDS: 8 puntos, se realiza una ecografía abdominal, que muestra una lesión sólida, en el lóbulo hepático derecho, de 3,5 cm y aspecto hipoecogénico, que en la tomografía se aprecia sólido e hipervascular en la fase arterial. El diagnóstico más probable es:

A) Colangiocarcinoma
B) Adenoma hepático
C) Carcinoma hepatocelular
D) Quiste hepático
E) Hemangioma hepático

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El antecedente de DHC y el aspecto hipervascular orientan fuertemente a que es un hepatocarcinoma. Los adenomas también son bien delimitados e hipoecogénico, pero suelen verse principalmente en mujeres en edad fértil, que usan ACO o en hombres que usan anabólicos.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 164 1.06.1.024 · Masa hepática

Un paciente de 69 años, con daño hepático crónico, por consumo de alcohol, score de Child Pugh B, acude a control. Al examen físico tiene ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas, sin encefalopatía. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina: 3,1 mg/dl, SGOT: 50 UI/L, SGPT: 39 UI/L, albúmina: 3,0 g/dl, FA: 110 UI/L. Se solicita una ecografía abdominal que, además de la ascitis, muestra dos lesiones hepáticas hipoecogénicas de 2,2 cm y 1,6 cm, respectivamente. En una imagen anterior, realizada hace 6 meses, se veían las mismas lesiones, pero de menor tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulos de regeneración
B) Adenomas hepáticos
C) Hemangiomas hepáticos
D) Hepatocarcinomas
E) Quistes simples hepáticos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hepatocarcinomas** (opción **D**). Clase sobre el enfoque global de la ictericia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Nódulos de regeneración, Adenomas hepáticos) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 79 1.06.1.024 · Masa hepática

Paciente con cirrosis hepática y dos lesiones hepáticas hipoecogénicas de 2 cm heterogéneas en ecografía. ¿Diagnóstico más probable?

A) Metástasis hepáticas
B) Absceso hepático piógeno
C) Hemangioma hepático
D) Carcinoma hepatocelular
E) Colangiocarcinoma intrahepático

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Carcinoma hepatocelular** (opción **D**). Carcinoma hepatocelular. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 54 1.06.1.024 · Masa hepática

Una paciente de 39 años, con antecedente de obesidad, se realiza una ecografía abdominal que muestra hígado graso leve, con presencia de un quiste hepático simple de 1,0 cm y un pólipo vesicular de 0,5 cm. La conducta más adecuada es:

A) Realizar biopsia por punción del pólipo
B) Controlar con una nueva ecografía en 6 meses
C) Realizar laparotomía exploradora
D) Realizar colecistectomía laparoscópica
E) Realizar punción del quiste hepático

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El hígado graso se trata con ejercicio, dieta y metformina. Los quistes simples son algo normal y frecuente. Los pólipos vesiculares menores a 1 cm se observan.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 98 · 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Una paciente de 55 años, con antecedente de daño hepático crónico por virus hepatitis C, consulta por cuadro de malestar general, asociado a febrículas, confusión y aumento de perímetro abdominal. Al examen abdominal destaca matidez desplazable. Se realiza paracentesis diagnóstica que muestra transudado y presencia de 300 leucocitos (100% polimorfonucleares). La conducta más adecuada en este caso es:

A) Administrar albúmina endovenosa
B) Realizar paracentesis evacuadora
C) Observar
D) Administrar antibióticos de forma empírica
E) Iniciar terapia con furosemida y espironolactona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una PBE. También hay que dar albúmina (1,5 g/Kg de peso el primer día y 1,0 g/Kg de peso al tercer día), pero los ATB son lo más importante. Se da Cefotaximo.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 129 · 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Paciente cirrótico hospitalizado con ascitis en tratamiento con cefotaxima por PBE. A las 72h persiste fiebre y deterioro. Cultivo del líquido ascítico: Escherichia coli. ¿Cuál es el significado clínico?

A) E. coli es el agente más frecuente en PBE; el tratamiento es correcto si hay sensibilidad
B) Cambiar a ceftriaxona
C) Agregar metronidazol
D) Cambiar a vancomicina
E) Realizar paracentesis evacuadora urgente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
coli es el microorganismo más frecuente en PBE (40-50% de los casos). Si el antibiograma confirma sensibilidad a cefotaxima, el tratamiento es correcto. La falta de respuesta obliga a revisar antibiograma y buscar complicaciones.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 159 · 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Un paciente de 67 años, cirrótico por consumo de alcohol, es traído por sus familiares, ya que ha presentado deterioro de su estado general y compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor superficial, tiene fétor hepático, y sus signos vitales muestran T°: 38,3°C, FC: 85x'. PA: 130/85 mmHg. El examen abdominal muestra ascitis a tensión. Presenta asterixis, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar su estudio?

A) Hemocultivos
B) Hemograma
C) Estudio de líquido ascítico
D) Tomografía axial computarizada de abdomen
E) Ecografía abdominal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Estudio de líquido ascítico). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Hemocultivos, Hemograma) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 115 · 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Un paciente de 56 años, con antecedente de daño hepático crónico, por consumo de alcohol, consulta por obnubilación, asociado a dolor abdominal e ictericia. Al examen físico se observa quejumbroso y tiene desorientación temporoespacial, fiebre de 38,3°C, ascitis moderada, ictericia de piel y mucosas y asterixis. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitos de 16.000, con recuento diferencial normal. Sus pruebas hepáticas muestran bilirrubina total: 5,2 mg/dl, albúmina: 2,8 g/dl, protrombinemia: 60%, GOT: 110 UI/L, GPT: 90 UI/L, GGT: 88 UI/L, FA: 120 UI/L. Child-Pugh categoría C. La conducta más adecuada en este paciente es:

A) Solicitar amonemia
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Iniciar lactulosa oral
D) Recuento de polimorfonucleares en líquido ascítico
E) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Esta es una pregunta que se ha repetido en múltiples ocasiones, con distintos enunciados y que se resumen en: "paciente con ascitis que le pasa cualquier cosa (ej. dolor, fiebre, desorientación, compromiso hemodinámico, HDA, etc.), lo primero a hacer es puncionarlo, para descartar PBE. Por tanto, la respuesta es el recuento de polimorfonucleares en la paracentesis diagnóstica (si es más de 250 por mm3 se confirma la PBE y se inicia cefotaximo ev más albúmina, prohibiendo la evacuación de la ascitis).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 117 · 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Un paciente de 55 años, alcohólico, con daño hepático crónico, es traído al servicio de urgencia por deterioro del estado general, dolor abdominal y fiebre de 38,5 grados Celsius. Al examen físico está quejumbroso, en sopor, con dolor a la palpación abdominal y ascitis severa. Se solicita un hemograma que muestra hemoglobina 15 mg/dl, blancos de 15.000 por mm3 y plaquetas de 190.000 por mm3 y sus pruebas hepáticas muestran un daño hepático crónico en etapa C de Child Pugh . ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio de este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Colangioresonancia
D) Estudio de líquido ascítico
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Probablemente tiene una PBE, que lo descompensa. De todos modos, todo cirrótico descompensado, con ascitis, debe estudiarse para descartar la PBE (peritonitis bacteriana espontánea).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 39 · 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Hombre con ascitis a tensión y fiebre y encefalopatía: a. Estudio liquido

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Staphylococcus aureus). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 175 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Un paciente con antecedente de cirrosis hepática por consumo de alcohol, suspendido hace algún tiempo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y tabaquismo, consulta por un cuadro de 7 días de evolución, caracterizado por desorientación, dolor abdominal, vómitos e ictericia. Al examen físico, presenta desorientación y lentitud del lenguaje, tiene frecuencia cardíaca: 89x', presión arterial 100/60 mmHg y asterixis. Al examen abdominal se evidencia ascitis grado 2 y dolor a la palpación abdominal. Sus pruebas hepáticas muestran: GOT 192 U/L, GPT 107 U/L, bilirrubina total 4 mg/dL y GGT 220 U/L. La protrombinemia es del 60%. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada para continuar con el estudio?

A) Solicitar amonemia
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Solicitar endoscopía digestiva alta
D) Realizar paracentesis diagnóstica
E) Solicitar ecografía abdominal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Evaluación de la Descompensación en Pacientes Cirróticos con Ascitis: En pacientes cirróticos con ascitis que experimentan cualquier tipo de descompensación, la evaluación diagnóstica debe comenzar con una paracentesis diagnóstica para descartar la peritonitis bacteriana espontánea.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 78 1.06.2.011 · Peritonitis bacteriana esp

Paciente con daño hepático crónico, sopor, fiebre, ictericia y ascitis a tensión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Estudio de líquido ascítico (paracentesis diagnóstica)
B) Iniciar antibiótico de amplio espectro empírico
C) Hospitalizar y tratar encefalopatía hepática
D) TAC de abdomen urgente
E) Transfundir y corregir coagulación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Estudio de líquido ascítico (paracentesis diagnóstica)** (opción **A**). Estudio de líquido ascítico (paracentesis diagnóstica). Bilirrubina >1.1 es alta; ictericia clínica aparece sobre 2.5-3 mg/dL De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 90 1.06.2.010 · Pancreatitis aguda

Un paciente obeso, con antecedente de hígado graso. Luego de una trasgresión ali- mentaria con abundante consumo de alcohol, presenta cuadro de dolor epigástrico irradiado a ambos costados, asociado a vómitos alimentarios, sensación febril e icteri- cia. Al examen físico, su presión arterial es de 110/70mmHg, con frecuencia cardiaca 100 por minuto, y al examen abdominal presenta dolor a la palpación de forma difusa, con abolición de ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

A) Isquemia mesentérica
B) Colangitis
C) Pancreatitis
D) Colecistitis
E) Coledcolitiasis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Pancreatitis** (opción **C**). Es una pancreatitis clásica. SEGUNDA PARTE. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 35 1.06.2.010 · Pancreatitis aguda

Un paciente presenta dolor epigástrico muy intenso, irradiado a ambos costados, . Tiene antecedente de una transgresión alimentaria y consumo de alcohol, el día anterior. Al examen físico se aprecia adolorido, con temperatura 38 grados, abdomen difusamente doloroso a la palpación, con disminución de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

A) Úlcera perforada
B) Isquemia mesentérica
C) Hepatitis
D) Colecistitis aguda
E) Pancreatitis aguda

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Pancreatitis aguda** (opción **E**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 121 1.06.2.010 · Pancreatitis aguda

Un paciente de 45 años, sin antecedentes, consulta por dolor epigástrico intenso asociado a vómitos biliosos. Al examen físico se encuentra frecuencia cardiaca en 90 por minuto, presión arterial 140/90, escleras levemente ictéricas, abdomen blando, doloroso a palpación epigástrica, blumberg (-). Se solicitan exámenes que muestran GOT 100mg/dL, GPT 110mg/dL, bilirrubina total 2 mg/dL, fosfatasas alcalinas 350mg/dL, lipasa 250mg. Ecografía abdominal que muestra vesícula de paredes delgadas, sin edema, con barro biliar visible y colédoco de 8mm. El diagnóstico más probable es:

A) Colangitis aguda
B) Pancreatitis aguda
C) Coledocolitiasis
D) Colecistitis aguda
E) Cólico biliar simple

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lipasa está mayor a 180. Además tiene una colédocolitiasis, pero manda la pancreatitis, por ser lo más grave.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 88 1.06.2.010 · Pancreatitis aguda

Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de dos días de evolución de dolor abdominal, localizado en hipocondrio derecho, que se irradia al dorso y se ha asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades y calofríos. Al examen físico se aprecia ictericia de piel y escleras, sus signos vitales muestran FC: 100x', PA: 110/68 mmHg, examen abdominal con abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación del epigastrio y el hipocondrio derecho, sin signos peritineales y con ruidos hidroaéreos presentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda
B) Pancreatitis aguda
C) Coledocolitiasis aguda
D) Colecistitis aguda
E) Hepatitis aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Pancreatitis aguda** (opción **B**). Clase sobre el enfoque global de la ictericia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Apendicitis aguda, Coledocolitiasis aguda) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 163 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Joven de 25 años con diarrea crónica de 8 meses, 5-6 deposiciones al día sin sangre, pérdida de peso de 7 kg, úlceras orales recurrentes, dolor abdominal periumbilical y fístula perianal. Colonoscopía: úlceras aftosas con mucosa normal entre ellas (patrón en empedrado). ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de intestino irritable
B) Colitis ulcerosa
C) Enfermedad de Crohn
D) Tuberculosis intestinal
E) Linfoma intestinal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Enfermedad de Crohn: compromiso transmural + patrón en empedrado + úlceras aftosas con mucosa intercalada normal + fístula perianal + úlceras orales + localización que puede ser cualquier tramo del tubo digestivo. La CU no tiene fístulas ni compromiso ileal típico ni úlceras orales.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 164 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Mujer de 35 años con diarrea crónica mucosanguinolenta de 6 meses de evolución, urgencia defecatoria, pujo y tenesmo. Colonoscopía: mucosa eritematosa, granular, con pseudopólipos, desde el recto continuo hasta el ángulo esplénico, sin mucosa sana intercalada. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Colitis isquémica
B) Colitis ulcerosa
C) Síndrome de intestino irritable
D) Colitis infecciosa
E) Enfermedad de Crohn

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Colitis ulcerosa: compromiso mucoso continuo desde el recto hacia proximal + diarrea mucosanguinolenta + tenesmo + pseudopólipos en endoscopía. No hay mucosa sana intercalada (a diferencia de Crohn). Tratamiento: 5-aminosalicilatos (mesalazina) tópicos + orales según extensión.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 110 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un paciente de 25 años presenta un cuadro de 3 semanas de dolor abdominal tipo cólico y diarrea acuosa, que en ocasiones es sanguinolenta. Además, ha presentado úlceras orales recidivantes y ha bajado de peso. Al examen físico tiene abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda y sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 4 semanas se realizó manejo quirúrgico de una fístula anorrectal. El diagnóstico más probable es:

A) Colitis parasitaria
B) Enfermedad de Cröhn
C) Enfermedad celíaca
D) Colitis ulcerosa
E) Colitis pseudomembranosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Las úlceras orales se ven tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Cróhn. La fístula anorrectal orienta fuertemente a enfermedad de Cróhn.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 26 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un hombre de 25 años consulta por un cuadro de 1 mes de evolución de diarrea, dolor abdominal y malestar general. Además ha tenido disentería en algunas ocasiones y ha bajado 4 kilogramos de peso. Se solicita una colonoscopía, que muestra signos de inflamación en el colon, con zonas de mucosa indemne y sin afectación del recto. ¿Cuál es el diagnóstico más

A) Colitis ulcerosa
B) Enfermedad de Cröhn
C) Colitis isquémica
D) Parasitosis intestinal
E) Colitis por Clostridium difficile

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una enfermedad inflamatoria, y por no afectar el recto y tener afectación discontinua, no puede ser colitis ulcerosa, sino enfermedad de Cröhn.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 16 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un paciente de 35 años consulta por un cuadro de dolor abdominal y diarrea de 3 meses de evolución, con 8 a 10 deposiciones líquidas al día, tanto diurnas como nocturnas. Presenta dolor abdominal 8po cólico con exacerbación en el hemiabdomen derecho. Además, al interrogatorio, refiere visión borrosa con enrojecimiento del ojo derecho y ajas orales recurrentes. También, relata baja de peso y presencia ocasional de sangre en las deposiciones. Al examen Fsico se observa pálido, con frecuencia cardíaca 90 lpm, presión arterial 125/72 mmHg y temperatura 37,2 °C. El abdomen está blando y sensible de forma difusa, con dolor más intenso en la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Coli2s ulcerosa
B) Coli2s infecciosa
C) Cáncer de colon
D) Enfermedad de Crohn
E) Síndrome de intes2no irritable con predominio de diarrea Mortalidad Mortalidad proporcional Mortalidad Mortalidad proporcional Patología cardiovascular 60/1000 50% 150/1000 71,4% Cáncer 30/1000 25% 30/1000 14,3% Otras causas de muerte 30/1000 25% 30/1000 14,3% Total 120/1000 100% 210/1000 100% Periodo inicial Periodo tardío

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene clínica de una enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Entre ellas, parece más enfermedad de Crohn, por el dolor en el lado derecho (la zona ileocecal es lo más frecuentemente afectado), las amas (el compromiso oral también se puede ver en la coliGs ulcerosa, pero orienta a Crohn) y el compromiso ocular (más frecuente en enfermedad de Crohn que en coliGs ulcerosa).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 103 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un hombre de 26 años consulta por dolor abdominal de 3 meses de evolución, asociado a diarrea acuosa, que en ocasiones ha presentado hematoquecia. Hace una semana se agrega marcado pujo y tenesmo, más aumento de la intensidad del dolor abdominal. Al examen físico tiene signos vitales normales y su abdomen es sensible a la palpación, con dolor a la palpación de la fosa iliaca y el flaco izquierdos, sin signos peritoneales. Los ruidos hidroaéreos se auscultan conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cröhn
B) Enfermedad celiaca
C) Colitis ulcerosa
D) Megacolon amebiano
E) Cáncer de colon

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Colitis ulcerosa** (opción **C**). Es una colitis ulcerosa clásica. No tiene elementos que hagan elegir a la enfermedad de Cröhn.. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 123 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Mujer de 29 años, sin antecedentes, con cuadro de tres semanas de dolor abdominal intermitente, de intensidad moderada, asociado a deposiciones con sangre en ocasiones y disentería. Al examen físico se aprecia levemente deshidratada, con dolor a la palpación abdominal profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

A) Colitis ulcerosa
B) Giardiasis
C) Divertículo de Meckel
D) Colitis isquémica
E) Enfermedad de Crohn

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una EII. No tiene ninguno de los elementos que orientan a Cröhn, por lo que hay que elegir CU. Si tuviera algo de Cröhn (abscesos perianales, malabsorción intestinal, fístulas, úlceras orales, ASCA+, compromiso de intestino delgado, compromiso en parches o discontinuo, masa, perforación, etc) sería Cröhn.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 110 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de un mes de evolución, asociado a diarrea y baja de peso de 6 kg. En algún momento, presentó deposiciones sanguinolentas. Se solicita una tomografía axial computarizada (TAC), que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin masas. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio diagnóstico?

A) Parasitológico de deposiciones
B) Endoscopía digestiva alta
C) Colonoscopía
D) Enteroscopía
E) Enteroclisis por TAC

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Enfermedad de Crohn: La clínica de la paciente es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal. Además, la TAC muestra un compromiso del intestino delgado, lo que sugiere una enfermedad de Crohn. En las enfermedades inflamatorias intestinales, el diagnóstico definitivo se realiza mediante una colonoscopía.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 135 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Una paciente de 17 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico, que se ha exacerbado en las últimas 3 semanas y que está asociado a deposiciones diarreicas intermitentes, las que dice haber tenido desde los 15 años, con aumento de la frecuencia en el último mes. Al examen físico presenta inyección ciliar bilateral, sus signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales; al examen abdominal presenta dolor leve a la palpación abdominal sin signos peritoneales y se detecta una masa palpable en el flanco derecho. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 31%, hemoglobina: 10.2 g/dL, VCM: 76 fL, HCM: 27 pg, glóbulos blancos: 10.000 por mm3, plaquetas: 320.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Crohn
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis parasitaria
D) Colitis ulcerosa
E) Cáncer de colon

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Enfermedad de Cröhn: El cuadro clínico es compatible con enfermedad inflamatoria intestinal con síntomas extraintestinales (oculares). La presencia de una masa sugiere fuertemente enfermedad de Cröhn. Si hubiese sido un adulto mayor, se hubiese sospechado un cáncer de colon.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 116 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Una paciente de 23 años, consulta por un cuadro de diarrea de tres meses de evo- lución asociada a sensación febril y fiebre cuantificada hasta 38,0°C. Además, ha pre- sentado disentería en algunas oportunidades y refiere entre otros síntomas, dolor arti- cular migratorio en las cuatro extremidades. Al examen físico se aprecian aftas orales y nódulos eritematosos dolorosos en la cara anterior de las piernas. Su examen abdomi- nal muestra un abdomen blando, doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad celiaca
B) Infección por salmonella
C) Déficit de IgA
D) Colitis ulcerosa
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una mala pregunta, porque la clínica orienta a enfermedad de Cröhn, que no aparecía en las enfermedades. Solo quedaba marcar la colitis ulcerosa, pero las úlceras orales no son complatibles.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 50 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un hombre de 35 años consulta por deposiciones abundantes y líquidas, que iniciaron hace 2 semanas y se presentan hasta 5 veces al día. Además, refiere malestar general y sensación febril. Dos meses atrás fue operado por una fístula perianal. Al examen físico tiene T°: 37,7°C, FC: 88x', PA. 120/80 mmHg, examen oral con tres úlceras; el examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, con negatividad de los signos peritoneales y presencia de ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infección por Shigella
B) Colitis ulcerosa
C) Enfermedad de Cröhn
D) Colitis pseudomembranosa
E) Infección por Entamoeba histolytica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Cröhn** (opción **C**). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 21 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un paciente de 45 años, con antecedente de colitis ulcerosa, diagnosticada a los 20 años, inactiva hace 10 años, desde hace una semana ha presentado episodios de deposiciones blandas, con presencia de sangre en escasa cantidad. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar rectosigmoidoscopía
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar parasitológico de deposiciones
D) Solicitar colonoscopía
E) Iniciar corticoides orales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La colitis ulcerosa aumenta el riesgo de cáncer de colon en más de 2 veces, en especial de recto. Además, cualquier persona con esos síntomas se debe estudiar con colonoscopía, aunque no tenga colitis ulcerosa.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 81 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Paciente joven con diarrea de larga data, sin mucosidad ni sangre, TAC con engrosamiento íleon distal, diagnóstico, *calprotectina fecal elevada (1500 creo): cáncer/Crohn/CU? (Es Crohn) Tenia mas pinta de cancer<—- no porque tenia 20 y tantos. Tenia 48 era viejo. Pero por el nivel de calprotectina y el compromiso de intestino delgado es Crohn...

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hemograma y VHS** (opción **A**). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 27 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un paciente de 23 años presenta dolor abdominal de 2 meses de evolución, asociado a deposiciones acuosas, que han ido en aumento, hasta presentar diarrea varias veces al día. Además ha tenido sensación de fiebre, y ha perdido 3 kilos de peso. Refiere también que en la última semana presentó un cuadro de hematoquezia abundante, con coágulos. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio de este paciente?

A) TAC de abdomen y pelvis
B) Colonoscopía
C) Coprocultivo y leucocitos fecales
D) Examen parasitológico seriado de deposiciones
E) Toxinas de Clostridium difficile en deposiciones

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Colonoscopía). Es una enfermedad inflamatoria intestinal, que se estudia con colonoscopía.. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 142 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Una paciente de 25 años consulta por diarrea de un mes de evolución, asociada a dolor abdominal tipo cólico y algunos episodios de hematoquecia. Además, tiene artralgias de las manos y rodillas, con artritis de la rodilla derecha. Al examen físico se observan úlceras orales y lesiones nodulares en la cara anterior de las piernas. El examen abdominal muestra abdomen blando sensible, sin masas. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus eritematosos sistémico
B) Enfermedad de Behcet
C) Colitis ulcerosa
D) Artritis reumatoide
E) Colitis por Clostridium difficile

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien las úlceras orales sugieren más una enfermedad de Cröhn que una colitis ulcerosa, el cuadro clínico es compatible con una enfermedad inflamatoria intestinal, con la artritis secundaria y eritema nodoso. El LES sí tiene úlceras orales, pero es rara la afectación digestiva. La enfermedad de Behcet sí tiene úlceras orales y genitales, más artritis, pero con afectación del SNC y SNP y sin afectación digestiva.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 116 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un paciente de 25 años consulta por diarrea, que inició hace 3 meses, que en ocasiones es sanguinolenta. Además presenta pujo y tenesmo frecuente y ha bajado 6 kilogramos de peso. Al examen físico, presenta dolor abdominal a la palpación del flanco izquierdo, ruidos hidroaéreos aumentados y úlceras orales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar endoscopía digestiva y anticuerpos antitransglutaminasa
B) Iniciar antibióticos orales
C) Solicitar colonoscopía
D) Solicitar ecografía abdominal
E) Pedir un TAC de abdomen y pelvis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Probablemente tiene una enfermedad de Cröhn (por las úlceras orales no es colitis ulcerosa). Se estudia con colonoscopía.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 12 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un hombre de 23 años consulta por dolor abdominal de 2 meses de evolución, que ha ido en aumento y se asocia a diarrea acuosa. Al examen físico se palpa abdomen sensible, con ruidos hidroaéreos conservados. Hace 2 días aumenta el dolor y la diarrea, por lo que se solicita una TAC de abdomen y pelvis, que muestra engrosamiento del íleon distal y del ciego, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Endoscopía digestiva alta
B) Resonancia magnética de abdomen
C) Ecografía abdominal
D) Colonoscopía
E) Parasitológico de deposiciones y coprocultivo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
No queda claro cuál es el diagnóstico, pero parece una enfermedad de Crohn, por lo que se estudia con colonoscopía. También podría ser un linfoma MALT, que se estudia igual.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 69 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Hombre con diarrea disentérica, aftas bucales y antecedente de fístula perianal tratada. ¿Diagnóstico más probable?

A) Colitis ulcerosa
B) Síndrome de intestino irritable
C) Colitis infecciosa por Shigella
D) Enfermedad de Crohn
E) Colitis isquémica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Crohn** (opción **D**). Enfermedad de Crohn. Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 103 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Una paciente de 35 años consulta por diarrea de 3 meses de evolución asociada a dolor abdominal, con deposiciones frecuentes de 5 a 6 veces durante el día y 1 a 2 veces en la noche. En ocasiones ha presentado escasos restos de sangre y ha bajado 17 kg de peso desde el inicio de los síntomas. Al examen Fsico presenta signos vitales normales. Se constata IMC de 41,8 y se palpa abdomen blando, sensible de manera difusa, sin signos peritoneales, masas, ni visceromegalias. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) An2cuerpos an2-transglutaminasa
B) Endoscopía diges2va alta
C) Ecogra:a abdominal
D) Coprocul2vo y parasitológico de deposiciones
E) Colonoscopía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Ya sea que se sospeche una enfermedad inflamatoria intestinal (lo más probable) o un cáncer de colon, se debe estudiar con colonoscopía completa.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 176 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Un paciente de 31 años consulta por 2 meses de evolución de dolor abdominal y deposiciones diarreicas, inicialmente 3 veces al día, con aumento a 7 veces al día en las últimas 2 semanas. En el examen físico tiene FC: 88x', PA: 130/82 mmHg, T°: 36,0°C, abdomen blando, depresible, con meteorismo, sin masas ni visceromegalias, con ruidos hidroaéreos presentes y sin signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cröhn
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis ulcerosa
D) Colitis parasitaria
E) Síndrome de intestino irritable

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico Diferencial de la Diarrea Crónica: En un paciente con diarrea crónica (mayor a 4 semanas) que ha empeorado recientemente, la colitis ulcerosa es el diagnóstico más probable, considerando la evolución temporal de los síntomas. La enfermedad de Crohn es menos probable en ausencia de otros síntomas específicos. El síndrome del intestino irritable y la enfermedad celíaca habrían tenido una historia más prolongada en un paciente de esa edad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 127 · 1.06.1.018 · Enfermedad inflamatoria in

Una paciente de 27 años consulta por deposiciones diarreicas de 3 semanas de evolución, asociadas a mucho pujo y tenesmo rectal. Refiere rectorragia ocasional escasa. Su examen físico muestra T°: 37°C, PA: 122/78 mmHg, FC: 72x', abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación hipogástrica y fosa iliaca izquierda. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Test de sangre oculta en deposiciones
B) Parasitológico de deposiciones
C) Colonoscopía
D) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis
E) PCR para Clostridioides difficile

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Colonoscopía). Clase sobre las enfermedades inflamatorias intestinales: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 121 · 1.06.1.004 · Cáncer gástrico

Un paciente de 55 años con pirosis, que es mayor postprandial, que inició hace 2 meses y que ha aumentado en el último tiempo. Además presenta baja de peso de 4 kilogramos en dicho periodo y refiere dolor abdominal, que aumenta al palpal el epigastrio. Además en el último tiempo se han agregado vómitos postprandiales. ¿Cuál es el examen que debe solicitarse para estudiar a este paciente?

A) Endoscopía digestiva alta
B) pH-metría de 24 horas
C) TAC de abdomen
D) Ecografía abdominal
E) Marcadores tumorales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Endoscopía digestiva alta). Parece un cáncer gástrico. Siempre lo primero es confirmarlo con EDA y biopsia. La necrosis tubular aguda (NTA) es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda de tipo renal. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 91 1.06.1.004 · Cáncer gástrico

Un hombre de 57 años presenta epigastralgia, inapetencia y baja de peso, de 2 meses de evolución, a lo cual se agrega un episodio de melena, por el que consulta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer gástrico
B) Úlcera gastroduodenal
C) Cáncer de esófago
D) Linfoma gástrico, asociado a mucosa
E) Gastritis erosiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un cáncer gástrico clásico. El episodio de melena da cuenta de una HDA. La úlcera habría tenido dolor urente, sin baja de peso, aunque sí podría tener melena. El cáncer de esófago tendría disfagia, más que inapetencia, aunque sí podría tener baja de peso.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 133 1.06.1.004 · Cáncer gástrico

Paciente de 65 años, con antecedente de tabaquismo crónico de 30 paquetes/año, consulta por cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, pirosis y baja de peso de 10 kg. Al examen físico se aprecia decaído, deshidratado y muy enflaquecido, con leve edema en extremidades inferiores simétrico. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer pulmonar
B) Cáncer gástrico
C) Cáncer de esófago
D) Cáncer de páncreas
E) Cáncer de duodeno

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La pirosis y la gran baja de peso orienta más a estómago. No tiene disfagia que es lo clásico del Cáncer de esófago. El edema es por la desnutrición proteica.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 119 1.06.1.009 · Constipación

Una paciente de 27 años presenta constipación de 3 años de evolución, con deposiciones caprinas, duras, que evacua una vez a la semana. Se realiza una radiografía de abdomen que muestra dolicocolon, con contenido en toda su extensión. ¿Cuál es el el tratamiento más adecuado?

A) Laxantes osmóticos
B) Laxantes de contacto
C) Cambios de hábitos
D) Proquinéticos
E) Cirugía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El dolicolon (colon largo) no ha demostrado asociarse efectivamente a constipación. La conducta es tratar la constipación en un paciente joven, es decir, mejorar los hábitos. También es aconsejable aumentar la fibra en la dieta. Los laxantes se desaconsejan, ya que producen dependencia y solo se usan en problemas transitorios o cuando fallan las medidas generales.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 42 1.06.1.009 · Constipación

Un paciente consulta por dolor anal, que aparece luego de defecar y persiste, asociándose a sangrado rectal, tras la defecación. Al examen físico presenta hipertonía del esfínter anal interno. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar analgésicos y baños de asiento
B) Resolver quirúrgicamente
C) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis y periné
D) Solicitar colonoscopía
E) Indicar laxantes

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una fisura anal aguda. Se trata con baños de asiento y pueden servir los analgésicos. Solo la crónica se trata con laxantes y si no responde se opera.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 174 1.06.1.007 · Colestasia

Una paciente de 54 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran SGOT: 43 UI/L, SGPT: 70 UI/L, GGT: 433 UI/L, FA: 531 UI/L, bilirrubina total: 3,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 88%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A) Colestasia por esteatosis hepática
B) Cirrosis biliar primaria
C) Colestasia por compresión externa
D) Colangitis esclerosante primaria
E) Colangitis esclerosante secundaria

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una CBP (cirrosis biliar primaria) clásica: mujer de edad media, con colestasia crónica, con elevación prominente de las fosfatasas alcalinas; aunque falta la clínica de astenia, que es el síntoma más frecuente. No tiene factores de riesgo para la esteatosis hepática (hígado graso) y, además, suele cursar con hepatitis y no colestasia. La colestasia por compresión externa, suele ser por cáncer y viene con mucha ictericia (no es el caso). La colangitis esclerosante primaria puede tener un cuadro similar, pero en lugar de ser una mujer de edad media, suele ser en hombres, con antecedente de colitis ulcerosa.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 136 1.06.1.007 · Colestasia

Una mujer de 49 años consulta prurito generalizado, que es mayor en las palmas y plantas y que aumenta en la noche. Se realiza pruebas hepáticas que muestran GOT: 48 UI/L, GPT: 50 UI/L, GGT: 710 UI/L, FA: 689 UI/L, bilirrubina total: 2,0 mg/dl y bilirrubina directa: 0,6 mg/dl, albúmina: 4,0 g/dl y protrombinemia 100%. El examen de elección para proseguir el diagnóstico es:

A) Cuantificación de inmunoglobulina E sérica
B) Colangioresonancia
C) Ácidos biliares
D) Anticuerpos antinucleares
E) Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una colestasia clínica (prurito palmoplantar mayor en la noche) y de laboratorio (elevación de la GGT, FA y bilirrubina). Por la edad y por ser mujer, lo más probable es que sea una cirrosis biliar primaria (CBP), por lo que se estudia con los AMA (anticuerpos antimitocondriales) y luego se confirma con la biopsia hepática (se trata con ácido ursodeoxicólico, que ayuda a disminuir los síntomas). La clínica más frecuente de la CBP es con marcada astenia y eventualmente prurito e ictericia. La CIE (colestasia intrahepática del embarazo) tiene la misma clínica, solo que en el embarazo y se resuelve con el parto.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 49 1.06.1.007 · Colestasia

Una paciente de 55 años, se realiza exámenes como parte de chequeo médico, que muestran GOT: 54 UI/L, GPT: 70 UI/L, GGT: 654 UI/L, FA: 455 UI/L, bilirrubina total: 1,0 mg/dl, albúmina: 3,7 g/dl y protrombinemia: 90%. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A) Coledocolitiasis
B) Cirrosis biliar primaria
C) Colestasia por obstrucción neoplásica
D) Colangitis esclerosante primaria
E) Colangitis esclerosante secundaria

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene colestasia en las pruebas hepáticas, sin hepatitis (por las GOT y GPT mínimamente elevadas) ni falla hepática (protrombinemia y albúmina normales). Por ser mujer y de esa edad lo más probable es una CBP, la que, además, se demora en elevar la bilirrubinemia, afectando mucho más las FA y luego la GGT. La coledocolitiasis tendría dolor y mucha más ictericia. El cáncer produce bastante ictericia también. La CEP (opción D) suele asociarse a colitis ulcerosa o enfermedad de Cröhn y afectar más a hombres.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 118 1.06.1.007 · Colestasia

Una paciente de 40 años presenta marcada astenia y prurito intenso, en particular en las manos, que no ha respondido al tratamiento antihistamínico, indicado por el dermatólogo. En sus exámenes tiene hematocrito: 42%, blancos: 5.000, con 9% de eosinófilos, GOT: 58 UI/L, GPT: 39 UI/L, GGT: 300 UI/L, bilirrubina 2,0 UI/l, FA: 700 UI/L. ¿CUál es el examen para continuar el estudio?

A) Serología de virus hepatitis
B) Anticuerpos antinucleares
C) Ecografía hepática
D) Parasitológico de deposiciones
E) Anticuerpos antimitocondriales

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Cuadro de cirrosis biliar primaria. Se estudia con anticuerpos antimitocondriales (AMA). Luego la Biopsia hepática).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 20 1.06.1.007 · Colestasia

Un paciente de 38 años, con antecedente de colitis ulcerosa, desde hace 5 años con buen control, consulta por astenia y prurito de 2 meses de evolución, que han ido en aumento y que se ha asociado a ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran Bilirrubina: 3,3 mg/dl, bilirrubina directa: 2,4 mg/dl, FA: 512 UI/L, gama glutamil-peptidasa: 617 UI/L, GOT: 180 UI/L, GPT: 110 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Colangitis esclerosante primaria
B) Colangiocarcinoma
C) Hepatitis autoinmune
D) Coledocolitiasis
E) Colangitis biliar primaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una CEP clásica, que se asocia a colitis ulceros (ambas marcador ANCA) y cursa con una colestasia. Se diagnostica con colangioRMN, aunque es correcto iniciar el estudio con una ecografía.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 13 1.06.1.007 · Colestasia

Un paciente de 38 años, con antecedente de colitis ulcerosa, desde hace 4 años, consulta por astenia y prurito de 5 meses de evolución, que han ido en aumento y que se ha asociado a ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran Bilirrubina: 6 mg/dl, Bilirrubina directa: 4,1 mg/dl, FA: 412 UI/L, GGT: 507 UI/L, GOT: 180 UI/L y GPT: 120 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Colangitis esclerosante
B) Esteatohepatitis
C) Hepatitis autoinmune
D) Coledocolitiasis
E) Cirrosis biliar primaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una colangitis esclerosante primaria clásica (se asocia a colitis ulcerosa y tiene patrón colestásico).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 6 1.06.1.007 · Colestasia

Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace meses, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 42 UI/L, GPT: 63 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L y bilirrubina de 6,4 mg/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) TAC de abdomen
B) Ecografía abdominal
C) Endoscopía digestiva alta y biopsia
D) Colangioresonancia
E) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una coledocolitiasis residual (hasta 2 años después de la colecistectomía; luego de ese tiempo, se llama coledocolitiasis recurrente). La coledocolitiasis se estudia actualmente, de manera preferente con la colangioresonancia, ya que permite identificar de manera no invasiva los cálculos que se pueden extraer con la CPRE y los que requieren cirugía (ej. localización muy alta). El orden en que se estudia es el siguiente: 1. La ecografía abdominal es el examen de primera línea y puede mostrar dilatación de la vía biliar (mayor a 7 mm), 2. La colangioRMN es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y se pide después de la Eco y 3. La CPRE es el examen diagnóstico terapéutico, que solo se pide I. si hay clínica de colangitis o II. si la colangioRMN ve los cálculos en el colédoco, aunque también se pide III. si la Eco misma ve los cálculos y no solo signos indirectos, como la dilatación (en este caso no se pide la colangioRMN).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 169 1.06.1.007 · Colestasia

Una mujer de 27 años con antecedente de colecistectomía por colelitiasis hace un año, consulta por dolor epigástrico de 24 horas de evolución, de carácter intermitente, que se irradia a la región dorsal. El dolor se acompaña de vómitos alimentarios y coluria el día de hoy. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran bilirrubina total: 3,9 mg/dl, bilirrubina directa: 2,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 200 U/L, GPT: 53 U/L, GOT: 45 UI/L, GGT: 58 U/L, albuminemia: 4,2 g/dl y protrombinemia: 100%. La ecografía abdominal muestra una vía biliar intrahepática de características normales y conducto común de 10 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis postquirúrgica de la vía biliar
B) Coledocolitiasis
C) Colangitis aguda
D) Cáncer de vesícula biliar
E) Síndrome de Mirizzi

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Coledocolitiasis Residual: La coledocolitiasis residual puede ocurrir hasta un año después de una colecistectomía. Se caracteriza por dolor e ictericia con obstrucción biliar. Las pruebas hepáticas mostrarán un patrón colestásico, y la ecografía puede mostrar una dilatación del conducto biliar común (mayor a 7 mm).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 54 1.06.1.007 · Colestasia

Pregunta 54 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 45 años consulta por astenia de 8 meses de evolución, asociada a prurito. Hace 2 meses se agrega ictericia y acumulación de grasa en los pliegues cubitales, poplíteos y alrededor de los ojos. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran bilirrubina: 4,9 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 655 UI/L, GOT: 88 UI/L, GPT: 76 UI/L, GGT: 230 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Hepatitis autoinmune
B) Cirrosis idiopática
C) Colédocolitiasis
D) Cirrosis biliar primaria
E) Cirrosis biliar secundaria

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una CBP clásica, tanto por ser una mujer de esa edad, como por la colestasia crónica, con xantomas, que son una manifestación frecuente.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 102 1.06.1.007 · Colestasia

Un paciente de 30 años consulta por ictericia de larga data, que suele aumentar en ciertos periodos. Se solicitan pruebas hepáticas que se informan como bilirrubina total: 3,0 mg/dl, bilirrubina directa: 0,5 mg/dl, GGT: 50 UI/L, GPT: 30 UI/L, GOT: 40 UI/L y fosfatasas alcalinas: 90 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Anemia hemolítica
B) Colangitis esclerosante primaria
C) Síndrome de Dubin Johnson
D) Coledocolitiasis
E) Síndrome de Gilbert

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome de Gilbert** (opción **E**). Es un síndrome de Gilbert clásico (hiperbilirrubinemia de predominio no conjugado, sin otras alteraciones).. La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como caída de la filtración glomerular que lleva más de 3 meses. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 123 1.06.2.006 · Encefalopatía hepática

Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por alcohol, presenta desorientación, lenguaje incoherente y tendencia a la somnolencia. Al examen físico presenta ictericia, arañas vasculares en la cara y el pecho, asterixis y compromiso cualitativo de conciencia. ¿Qué fármaco es el más adecuado para su tratamiento?

A) Amonio
B) N-acetil-cisteína
C) Risperidona
D) Donepezilo
E) Lactulosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La encefalopatía hepática se trata con lactulosa. Sin embargo lo más importante siempre es descartar patología descompensante (infecciones). El amonio sirve para hacer el diagnóstico: se eleva la amonemia en la encefalopatía hepática

---

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 127 1.06.1.019 · Hepatitis aguda A no compl

Un paciente de 32 años regresa de un viaje a un país vecino. A los pocos días presenta un cuadro de 5 días de fiebre, asociado a malestar general, que es seguido luego de dolor abdominal, ictericia y orinas oscuras. Al examen físico está ictérico, con dolor a la palpación del hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis alcohólica
D) Colédocolitiasis
E) Fiebre tifoidea

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hepatitis A** (opción **A**). Cuadro clásico. Clase densa sobre hepatitis aguda y crónica. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 23 1.06.1.019 · Hepatitis aguda A no compl

Una paciente de 24 años, que hace 1 semana inicia cuadro de fiebre, dolores os- teoarticulares, ictericia. Como antecedente, hace tres semanas regresó de un viaje al ca- ribe. Se solicitan exámenes que muestran GOT: 1.210 UI/L, GPT: 1.120 UI/L, bilirrubina de 12 mg/dL. El examen inicial para el diagnóstico etiológico es:

A) IgG anti VHA
B) Anticuerpos anti VHC
C) Ag VHBs
D) IgM VHA
E) Anticuerpos antinucleares

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **IgM VHA** (opción **D**). Lo primero a descartar, siempre es la hepatitis A, con IgM-VHA. Si no, se busca la B, con Ag-VHBs.. Clase densa sobre hepatitis aguda y crónica. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 50 1.06.1.029 · Tumores de colon

Un paciente de 70 años, consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación, alternado con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información. En sus exámenes destaca hematocrito: 36% y hemoglobina de 12 g/dl. ¿Qué examen debe solicitarse a continuación?

A) Test de sangre oculta en deposiciones
B) Ecografía abdominal
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Colonoscopía
E) Rectosigmoidoscopía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un cuadro sugerente de cáncer de colon (constipación y anemia en adulto mayor), que se estudia con colonoscopía.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 31 1.06.1.029 · Tumores de colon

Un paciente de 45 años nota cambio en el hábito intestinal desde hace dos meses, requiriendo mayor esfuerzo defecatorio. Además, ha notado presencia ocasional de mucosidad y sangre en las deposiciones. Su examen físico muestra signos vitales normales y la exploración abdominal no presenta alteraciones ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada para iniciar su estudio?

A) Ecografía abdominal
B) TAC abdominal
C) Colonoscopía
D) Rectosigmoidoscopía
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cáncer colorrectal: La sospecha diagnóstica es un cáncer colorrectal. Si bien se puede iniciar el estudio con una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, se recomienda la exploración de todo el colon, por lo que la colonoscopía es la respuesta correcta.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 28 1.06.1.029 · Tumores de colon

Un paciente de 64 años presenta dolor abdominal desde hace un mes, asociado a cambio en el hábito intestinal. Su examen físico no aporta mayor información. Se había realizado un hemograma que muestra una anemia microcítica. ¿Qué examen se debe solicitar?

A) Colonoscopía
B) Radiografía simple de abdomen y pelvis
C) Ecografía abdominal
D) Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Colonoscopía). La sospecha es un cáncer de colon.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 175 1.06.1.029 · Tumores de colon

Paciente mayor de 50 años con pólipo resecado en colonoscopía: adenoma velloso con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la conducta?

A) Colonoscopía de control en 1 año
B) Colonoscopía de control en 3 años
C) Colonoscopía de control en 5 años
D) Hemicolectomía profiláctica
E) Colonoscopía de control en 10 años

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Colonoscopía de control en 3 años** (opción **B**). Colonoscopía de control en 3 años. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 1 1.06.1.029 · Tumores de colon

Una paciente de 92 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer por lo que está institucionalizada, presenta un cuadro de astenia, debilidad, baja de peso de 6 kilos en los últimos dos meses, asociado a hematoquesia intermitente en algunas oportunida- des, que los familiares atribuyen a hemorroides externos. Al examen físico presenta un abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes. Su piel se aprecia algo pálida y sus signos vitales son normales. ¿Con que examen debe iniciarse el estudio en esta paciente?

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Resonancia magnética de abdomen y pelvis
D) Colonoscopía corta
E) Colonoscopía completa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Colonoscopía completa). Se sospecha un cáncer de colon, que se estudia con colonoscopía completa. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 14 1.06.1.029 · Tumores de colon

Paciente 50 años aprox con cambio de hábito intestinal y baja de peso 8 kilos: a. colonoscopía

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 68 1.06.1.029 · Tumores de colon

Una paciente de 54 años presenta cambio en el hábito intestinal, asociada a distensión abdominal. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra un pólipo de 5 mm en la vesícula biliar, de aspecto homogéneo y delimitado. La conducta más adecuada es:

A) Indicar dieta baja en grasas
B) Realizar colecistectomía
C) Solicitar PCR ultrasensible
D) Realizar TAC de abdomen
E) Realizar colonoscopía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El pólipo vesicular no tiene importancia, por tener aspecto benigno. En cambio, el cambio en el hábito intestinal es algo que sugiere cáncer de colon y obliga a hacer una colonoscopía completa.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 160 1.06.1.029 · Tumores de colon

Un paciente de 55 años presenta cambio del hábito intestinal, caracterizado por diarrea acuosa, de 3 meses de evolución, asociada a dolor abdominal ocasional. Además, ha bajado 4 kilogramos de peso, desde el inicio de los síntomas. Se realizan exámenes de sangre, entre los que destacan hematocrito: 30%, Hemoglobina: 9,7 g/dl y VCM: 69 fl, albúmina: 2,8 g/dl y GOT: 40 UI/L. Tiene antecedente de un hijo con enfermedad celíaca. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en esta paciente?

A) Prueba terapéutica con dieta sin gluten
B) Ecografía abdominal
C) Colonoscopía
D) Detección de anticuerpos antitransglutaminasa en sangre
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
A pesar del antecedente de enfermedad celíaca en su hijo, la sospecha más importante es un cáncer de colon, por lo que se debe 14 lia... realizar una colonoscopía completa. Los signos de alarma (con 1 basta para hacer la colonoscopía) de este caso son cambio de hábito en adulto, baja de peso, anemia ferropénica.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 71 1.06.1.029 · Tumores de colon

Un paciente de 50 años, sin antecedente de importancia, se realiza una colonoscopía, como parte del screening de cáncer de colon, que muestra presencia de un pólipo de 6 mm de tamaño, ubicado en el colon descendente, el que se reseca y cuya biopsia es posteriormente informada como “adenoma velloso tubular con grado de displasia moderado”. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar hemicolectomía izquierda
B) Realizar mucosectomía del lecho del pólipo, por vía colonoscópica
C) Controlar con nueva colonoscopía en 6 meses
D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
E) Controlar con colonoscopía en 5 años

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar hemicolectomía izquierda** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 170 1.06.1.029 · Tumores de colon

Cancer ileo cecal algo asii no recuerdo la pregunta (no estaaa)

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 85 1.06.1.002 · Cáncer de páncreas

Un paciente de 60 años consulta por ictericia de dos semanas de evolución, que ha ido en aumento y se ha asociado a orinas oscuras. Como antecedente, es hipertenso y fumador de 5 paquetes-año. Su examen Fsico muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones en el examen abdominal. Se solicitan pruebas hepá8cas que muestran SGOT: 72 U/L, SGPT: 48 U/L, GGT: 115 U/L, fosfatasa alcalina 200: U/L y bilirrubina: 4,9 mg/dL, de predominio directo. Se realiza ecograFa abdominal que muestra vesícula biliar dilatada de 16 × 8 cm y dilatación de la vía biliar intrahepá8ca y extrahepá8ca. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Tumor de páncreas
B) Colangiocarcinoma
C) Colangi2s esclerosante primaria
D) Diveraculo duodenal
E) Colangi2s infecciosa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta algo difícil. Tiene una ictericia obstructiva, con un patrón colestásico, lo que hace sospechar un cáncer que obstruye la vía biliar. La dilatación de la vesícula (signo de Courvoisier-Terrier) y la dilatación de la vía biliar extrahepática es característica de la obstrucción distal del colédoco, por lo que lo más probable es que sea un cáncer de cabeza de páncreas. El antecedente de fumar también orienta a esa causa. El diverVculo duodenal es mucho más infrecuente. El colangiocarcinoma generalmente está ubicado más alto en la vía biliar.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 66 1.06.1.002 · Cáncer de páncreas

Adulto fumador con ictericia, coluria, prurito y acolia, con patrón colestásico. ¿Diagnóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Colangitis esclerosante primaria
C) Hepatitis viral colestásica
D) Colangiocarcinoma
E) Cáncer de páncreas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Cáncer de páncreas** (opción **E**). Cáncer de páncreas. Esta clase aborda cómo diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica en la práctica clínica, dado que el paciente habitualmente no sabe cuánto tiempo lleva con la creatinina elevada. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 147 1.06.1.002 · Cáncer de páncreas

Un paciente de 80 años presenta una clínica de 3 semanas de evolución de astenia, prurito e ictericia, asociada a malestar epigástrico. Además, refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Su examen físico muestra ictericia de piel y escleras, IMC: 19, signos vitales dentro de límites normales y examen abdominal que no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina plasmática: 12,4 mg/dl, con bilirrubina directa: 7,7 mg/dl, GOT: 120 UI/L, GPT: 89 UI/L, fosfatasas alcalinas: 870 UI/L y GGT: 688 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Coledocolitiasis
B) Cáncer ampular
C) Cáncer de páncreas
D) Colangiocarcinoma
E) Colangitis aguda

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cáncer de páncreas** (opción **C**). Esta clase aborda cómo diferenciar la insuficiencia renal aguda de la crónica en la práctica clínica, dado que el paciente habitualmente no sabe cuánto tiempo lleva con la creatinina elevada. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 52 1.06.1.002 · Cáncer de páncreas

Un paciente de 49 años, fumador, presenta un cuadro de dispepsia postprandial de 4 meses de evolución, asociado a astenia, palidez, ictericia y prurito, que aumenta en las noches. Se solicitan exámenes que muestran hemograma normal y pruebas hepáticas que resultan GOT: 23 UI/L, GPT: 28 UI/L, bilirrubina total: 9,7 mg/dl, bilirrubina directa: 8,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 322 UI/L y GGT: 131 UI/L, con protrombinemia 80% y albúmina: 3,2 g/dl. El examen de elección para el estudio de este paciente es:

A) Endoscopía digestiva alta
B) Ecotomografía abdominal
C) TAC abdominal
D) Colangiografía por RMN
E) Colangiografía endoscópica retrógrada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un probable cáncer con obstrucción de la vía biliar (colestasia silente), probable cáncer de páncreas, por ser fumador. Es una pregunta muy difícil, porque el examen de primera línea de la colestasia silente es la Ecografía abdominal, mientras que el examen de elección, para el cáncer de páncreas en específico, es el TAC abdominal con contraste. Finalmente, el mejor examen para ver las ictericias malignas en general es la colangioRMN y se suele pedir después de la Ecografía. Por la clínica con algo de dolor y el antecedente de fumar, asumiremos que estaban preguntando un cáncer de páncreas en específico, por lo que dejaremos como correcta la TAC.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 108 1.06.1.002 · Cáncer de páncreas

Un paciente de 58 años se realiza una ecograFa abdominal como parte del estudio de un cuadro de cons8pación crónica, la cual visualiza un quiste pancreá8co ubicado en la cabeza del páncreas de 6 mm de diámetro, sin precisar sus caracterís8cas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar marcadores tumorales
B) Solicitar resonancia magné2ca nuclear abdominal
C) Solicitar TAC de abdomen con contraste
D) Solicitar resección de la lesión y biopsia
E) Realizar seguimiento ecográfico en 6 meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El manejo del quiste pancreático se puede resumir en 1. Pequeño e incidental se estudia con RMN (aunque probablemente es benigno, no basta con la ecografía). 2. Grande o sospechoso se estudia con RMN más endosonografía y biopsia por punción. 3. Criterios claros de malignidad en la RMN se maneja con resección quirúrgica.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 147 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Un paciente de 61 años, con antecedente de haberse realizado una colonoscopía, hace un mes, la que estaba normal, consulta por una hemorragia digestiva baja abundante, con compromiso hemodinámico. Su frecuencia cardiaca es 120x' y su presión arterial, 90/60 mmHg. Se realiza endoscopía digestiva alta, que resulta normal y su hemograma muestra hematocrito de 19%, con hemoglobina: 6,3 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) TAC de abdomen y pelvis
C) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
D) Colonoscopía
E) Angiografía mesentérica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La colonoscopía es el examen de elección para enfrentar la HDB. La EDA se hizo, porque tenía hemodinamia inestable (siempre se debe hacer en ese caso). No importa que hace un mes tuviese una colonoscopía normal. Si no localiza, se procede a la cintigrafía con GR marcados o a la angiografía mesentérica.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 14 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Un paciente de 52 años presenta hematoquecia de 2 días de evolución, sin otros síntomas. Sus signos vitales muestran PA: 120/80 mmHg, FC: 75x' y T°: 36°C. Al examen físico, tiene leve palidez de mucosas y su abdomen es blando y depresible, sin masas ni visceromegalia y con preservación de los ruidos hidroaéreos. Se solicita una colonoscopía, que es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
B) Endoscopía digestiva alta
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Angiografía mesentérica
E) Enteroscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discutible. La hematoquecia con compromiso hemodinámico (HDB masiva) siempre se debe estudiar con EDA (en este caso falta el compromiso hemodinámico, pero creemos que es la respuesta correcta igual). La colonoscopía es el examen de elección en la HDB (y acá se hizo) y si no localiza, se sigue estudiando con pruebas radiológicas (cintigrafía o angiogiografía).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 148 · 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Un paciente de 55 años presenta múltiples episodios de hematemesis, de cerca de un litro, en la última hora. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 120 x', PA: 80/40 mmHg, con estigmas de daño hepático crónico y abdomen blando, sensible. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Administrar terlipresina endovenosa
B) Administrar cristaloides endovenosos
C) Instalar balón de Sengstaken
D) Realizar endoscopía digestiva alta
E) Transfundir glóbulos rojos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una HDA por várices esofágicas. De todas formas, independientemente de la causa de la hemorragia, toda HDA y HDB se manejan primeramente con reposición de la volemia EV, primeramente, con cristaloides (suero fisiológico o Ringer). La terlipresina sí está indicada, al igual que la EDA. El balón de Sengstaken se instala en lugares en que no hay EDA disponible, mientras se traslada a un centro de mayor complejidad.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 31 · 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Una paciente diabética, presenta hematemesis en 3 oportunidades. Su frecuencia cardíaca es 117x', su presión arterial es 90/60 mmHg. Al examen físico presenta arañas vasculares en la cara, ictericia en las escleras, abdomen blando depresivo e indoloro, con signos de ascitis. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina total: 4,3 mg/dl, hematocrito: 39%, INR: 1,8. La causa más probable de su hemorragia digestiva es:

A) Várices esofágicos
B) Úlcera gastroduodenal
C) Gastriris erosiva
D) Síndrome de Mallory Weiss
E) Esofagitis erosiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Várices esofágicos). Tiene clínica y exámenes de DHC, además de una HDA masiva, lo que orienta a várices esofágicos.. Clase sobre el enfoque global de la ictericia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 84 · 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Un paciente de 55 años, con antecedente de diabetes mellitus 2, consulta por un cuadro de hematemesis, seguida de malestar general. Al examen físico está pálido, con FC:110x', PA: 100/60 mmHg, constatándose obesidad. En sus exámenes destaca álbúmina: 3,0 g/dl; INR: 1,3; hematocrito: 30%, plaquetas: 77.000 por mm3, VCM: 105 fl y VHS: 20 mm/h. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Mallory Weiss
B) Úlcera gástrica
C) Úlcera duodenal
D) Várices esofágicas
E) Gastriris crónica atrófica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Son várices porque se presenta como hematemesis grave y los exámenes sugieren consumo de alcohol (VCM elevado) y daño hepático crónico (albúmina baja e INR levemente aumentado).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 156 · 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Un paciente de 45 años, luego de una transgresión alcohólica y alimentaria, presenta múltiples episodios de vómitos alimentarios, seguidos de hematemesis en una oportunidad. Su hemograma muestra hemoglobina de 9 g/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Várices esofágicas
B) Gastropatía erosiva
C) Úlcera péptica activa
D) Síndrome de Mallory Weiss
E) Gastritis isquémica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un síndrome de Mallory Weiss clásico: hematemesis precedida de vómitos alimentarios. Se produce una laceración esofágica por los vómitos. No se debe confundir con el síndrome de Böerhave, que es una perforación esofágica secundaria a los vómitos y que se presenta como una mediastinitis aguda.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 114 · 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Un paciente de 43 años acude al servicio de urgencia, luego de 7 días de ingesta alcohólica, porque presentó vómitos alimentarios intensos, seguidos de hematemesis. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor a la palpación epigástrica y en sus exámenes destaca hematocrito: 32%, GOT: 180UI/L, GPT: 130 UI/L, protrombinemia: 78%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Úlcera gástrica
B) Úlcera duodenal
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Gastritis erosiva
E) Várices esofágicas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Parece una hepatitis por consumo de alcohol (aunque la relación GOT/GPT no alcanza a ser mayor a 2), que luego vomitó y siguió con un Mallory Weiss clásico (desgarro esofágico por vómitos).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 40 · 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Una paciente de 19 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de rectorragia de dos días de evolución, que el día de hoy se volvió mucho más abundante. Al examen físico tiene FC: 117x', PA: 90/60 mmHg, palidez de piel y mucosas y examen abdominal con dolor difuso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Al preguntar dirigidamente, refiere antecedente de varios episodios de dolor periumbilical recurrente, de tipo urente, que había cedido de manera espontánea. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito: 27%, hemoglobina 8,1 g/dl, blancos: 5.000 por mm3 y plaquetas: 230.000 por mm3. También, se realiza colonoscopía de urgencia que muestra abundante sangre en todo el trayecto colónico, que fluye, además, por la válvula íleocecal. ¿Cuál es diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cröhn
B) Pólipo juvenil
C) Infección por Shigella
D) Divertículo de Meckel
E) Adenitis mesentérica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Divertículo de Meckel** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 75 1.06.2.007 · Hemorragia digestiva alta

Paciente con hemorragia digestiva masiva; colonoscopía muestra flujo activo de sangre fresca por válvula ileocecal. ¿Diagnóstico más probable?

A) Hemorragia por angiodisplasia cecal
B) Divertículo de Meckel
C) Enfermedad de Crohn ileal complicada
D) Intususcepción íleo-cólica
E) Carcinoma de ciego sangrante

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Divertículo de Meckel** (opción **B**). Divertículo de Meckel. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 125 1.06.1.001 · Ascitis

Un paciente fumador de 20 paquetes-año, que consume cerca de 5 g de alcohol al día los fines de semana, presenta moles8as abdominales inespecíficas y distensión abdominal progresiva desde hace 3 meses, a lo que en el úl8mo 8empo se agregó dolor abdominal. Se observa el paciente enflaquecido, con FC: 70x', PA: 130/80 mmHg y, en el examen abdominal, se constata asci8s a tensión, sin circulación colateral. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT: 48 U/L, GPT: 37 U/L, GGT: 59 U/L, bilirrubina total: 1,3 mg/dL, bilirrubina directa: 0,3 mg/dL, protrombinemia: 80% y albuminemia: 2,9 g/dL. Además, se realiza paracentesis diagnós8ca que muestra líquido ascí8co con 680 células/mm³, 80% mononucleares y 20% polimorfonucleares, glucosa: 116 mg/dL, proteínas: 1,36 g/dL y ADA: 3,4 U/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Peritoni2s bacteriana espontánea
B) Asci2s por hipertensión portal
C) Síndrome nefró2co
D) Tuberculosis peritoneal
E) Carcinomatosis peritoneal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una carcinomatosis tanto por la clínica de cáncer (fumador, baja de peso, cuadro progresivo) como por el análisis con un exudado mononuclear y ADA baja (se interpreta similar al estudio de líquido pleural). No es una PBE (peritoniGs bacteriana espontánea), ya que requiere más de 250 PMN y predominio PMN.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 99 1.06.1.001 · Ascitis

Un paciente de 64 años, con antecedente de cirrosis por NASH, con Child Pugh C, en tratamiento con carvedilol. Hace 1 semana presenta ascitis a tensión, por lo que se indica furosemida y espironolactona. Desde entonces, ha subido 4 kg de peso y al examen físico presenta FC: 90 por minuto, PAM: 72 mmHg, ascitis grado III. En sus exámenes destaca bilirrubina 2,5 mg/dl, INR 1,34, cretininemia: 3,1 mg/dl, Na: 122 mEq/L, K 5.5: mEq/L, Cl: 100 mEq/L y polimorfonucleares: 230 por mm3 en el líquido ascítico. ¿Cuál es la conducta más adeudada?

A) Administrar ceftriaxona i.v.
B) Administrar solución fisiológica i.v.
C) Aumentar la dosis de diuréticos
D) Realizar paracentesis evacuadora y administrar albúmina i.v.
E) Suspender el carvedilol

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una ascitis a tensión, en la que se descartó PBE (menos de 250 PMN), por lo que está indicado la paracentesis evacuadora, con albúmina en dosis de 8 g i.v. por litro de líquido sacado.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 90 1.06.4.010 · Estudio de perfil hepático

Una paciente de 26 años consulta por dispepsia de varios meses de evolución. Al examen físico se observa ictericia de piel y escleras. Tiene antecedente de alteraciones en sus pruebas hepáticas, hace 2 años. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran bilirrubinemia total: 2,2 mg/dl, bilirrubina directa: 0,3 mg/dl, SGOT: 26 UI/L, SGPT: 23 UI/L, GGT: 46 UI/L, FA: 65 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Colangitis esclerosante primaria
B) Síndrome de Gilbert
C) Colestasia intrahepática
D) Hepatitis en resolución
E) Cirrosis biliar primaria

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La dispepsia probablemente es de tipo funcional. La única alteración de las pruebas hepáticas es una hiperbilirrubinemia, de predominio indirecto, por lo que es un Sd. de Gilbert. Las colestasias tendrían elevación de la GGT, FA y bilirrubina directa (A, C y E), la hepatitis tendría elevación de la GOT y GPT (D). SEGUNDA PARTE

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 23 1.06.4.010 · Estudio de perfil hepático

Un paciente de 18 años tiene tendencia a tener una coloración ictérica de la piel. Al examen físico presenta escleras de tinte subictérico, sin otras alteraciones. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran bilirrubina total: 2,3 mg/dl, bilirrubina directa: 0,3 mg/dl, FA: 70 UI/L, GGT: 50 UI/L, SGOT: 35 UI/L, SGPT: 40 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hepatitis
B) Anemia hemolítica
C) Síndrome de Dubin Johnson
D) Síndrome de Gilbert
E) Síndrome de Crigler Najjar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome de Gilbert** (opción **D**). Es un síndrome de Gilbert clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 104 1.06.1.015 · Enfermedad celiaca

Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Se solicitan exámenes, entre los que destaca anemia ferropénica. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parasitosis intestinal
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis ulcerosa
D) Enfermedad de Cröhn
E) Enteropatía perdedora de proteínas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad celíaca** (opción **B**). Es una enfermedad celíaca clásica del adulto (diarrea y ferropenia).. Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 111 1.06.1.015 · Enfermedad celiaca

Una paciente de 23 años, vegetariana estricta, consulta por diarrea de algunos meses de evolución, asociada a baja de peso. Además, trae exámenes, entre los que destaca anemia microcítica e hipoalbuminemia. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parasitosis intestinal
B) Enfermedad celíaca
C) Colitis ulcerosa
D) Enfermedad de Cröhn
E) Enteropatía perdedora de proteínas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Que sea vegetariana aumenta el riesgo de déficit de B12, pero la anemia ferropénica y la hipoalbuminemia sugieren enfermedad celíaca.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 25 1.06.1.015 · Enfermedad celiaca

Una paciente de 24 años, presenta un cuadro de amenorrea y baja de peso, asociada a náuseas y dolor abdominal de varios meses de evolución. Tiene antecedente de una hermana gemela con hipotiroidismo. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hematocrito: 28%, balncos: 9.600 por mm3, plaquetas: 340.000 por mm3, bilirrubina: 1,1 mg/dl, GOT: 155 UI/L, GPT: 120 UI/L. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?

A) Solicitar IgM para VHA
B) Realizar biosia hepática
C) Solicitar colonoscopía
D) Solicitar ecografía abdominal
E) Solicitar anticuerpos antitransglutaminasa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar anticuerpos antitransglutaminasa** (opción **E**). La sospecha es una enfermedad celíaca y aunque sobra la hepatitis, es lo más probable.. Tratamiento celíaca: dieta sin gluten estricta; control con anticuerpos que negativizan al año De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 73 1.06.1.015 · Enfermedad celiaca

Paciente con hipotiroidismo, diarrea acuosa de meses y palidez. ¿Diagnóstico más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Colitis microscópica
C) Hipotiroidismo como causa directa de diarrea
D) Síndrome de intestino irritable
E) Gastroenteritis crónica eosinofílica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Enfermedad celíaca** (opción **A**). Enfermedad celíaca. Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 98 1.06.1.015 · Enfermedad celiaca

Una paciente de 30 años, con antecedente de hipotiroidismo, en tratamiento, consulta por diarrea de 3 meses de evolución, no disentérica, asociada a baja de peso y artralgias. Al examen físico destacan lesiones pruriginosas y vesiculares en el tronco y extremidades. El diagnóstico más probable es:

A) Colitis ulcerosa
B) Enfermedad celíaca
C) Enfermedad de Cröhn
D) Lupus
E) Trastorno digestivo funcional

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La primera parte es compatible con A, B y C. Sin embargo, las lesiones cutáneas descritas son una dermatitis herpetiforme, que se asocia a la enfermedad celíaca. En cambio, las EII (A y C) se asocian a eritema nodoso y pioderma gangrenoso, como manifestaciones cutáneas.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 125 1.06.1.015 · Enfermedad celiaca

Una paciente de 18 años, diabética tipo 1 en tratamiento con insulina glargina e insulina cristalina en esquema intensificado, consulta por un cuadro, que inició hace 2 meses, caracterizado por deposiciones líquidas frecuentes, sin mucosidad, asociadas a malestar abdominal y baja de peso de 4 kilogramos. Al examen físico, se aprecia pálida, tiene signos vitales normales y su abdomen es blando, depresible, sensible a la palpación profunda, sin irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Síndrome de intestino irritable, asociado a diarrea
C) Enteropatía perdedora de proteínas
D) Enfermedad inflamatoria intestinal
E) Diarrea viral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Enfermedad celíaca** (opción **A**). Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 60 1.06.1.015 · Enfermedad celiaca

Ca normal PTH elevada vitamina D baja P bajo, calcio urinario bajo + anemia Ferritina 5.

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hiperparatiroidismo Terciario
C) Enfermedad celiaca(ojo tenía ferritina en 5, lo que orientaba a enf. celiaca)
D) Osteoporosis
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Enfermedad celiaca(ojo tenía ferritina en 5, lo que orientaba a enf. celiaca)). Clase sobre el síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa y galactosemia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 29 1.06.1.021 · Hepatitis crónica

Un paciente asintomático se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran una SGOT: 432 UI/L y SGPT: 310 UI/L. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo el año 1992, que requirió de transfusiones. ¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?

A) Antígeno de superficie de VHB
B) IgM para VHA
C) Test de HOMA
D) Anticuerpos antinucleares y anticitoplasma de neutrófilo
E) Anticuerpos totales contra VHC

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una hepatitis crónica. El antecedente de transfusión orienta a hepatitis C, pero la verdad es que debe estudiarse con más exámenes, como por ejemplo el Ag VHBs, por lo que es una mala pregunta. Antes del año 2000, los casos de hepatitis B eran casi cero, por lo que no puede ser.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 30 1.06.2.005 · Diarrea aguda

Un paciente de 34 años lleva 48 horas con dolor abdominal tipo cólico, que ha ido en aumento, asociado a deposiciones líquidas abundantes y sensación febril. Al examen físico tiene temperatura axilar: 37,1 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, presenta dolor a la palpación del abdomen, mayor en la fosa iliaca derecha. No tiene signo de Blumberg. Se solicita una ecografía abdominal que muestra inflamación del íleon distal y del colon derecho y se ve el apéndice con leve edema de la pared y un coprolito en su base. ¿Cuál es el

A) Apendicitis aguda
B) Enteritis infecciosa
C) Diverticulitis aguda
D) Enfermedad de Cröhn
E) Colitis isquémica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Enteritis infecciosa). En mi opinión es una simple diarrea aguda.. Clase sobre el manejo del cuerpo extraño digestivo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 84 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Un hombre de 30 años presenta pirosis frecuente, por lo que se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una esofagitis por reflujo, grado A. Se inician inhibidores de la bomba de protones por 6 meses. Al control refiere buena respuesta, sin embargo, los síntomas recurren al suspender el tratamiento. La conducta más adecuada es:

A) Repetir la endoscopía digestiva alta
B) Solicitar pH-metría esofágica
C) Indicar inhibidores de la bomba de protones
D) Solicitar manometría esofágica
E) Cambiar a antihistamínicos H2

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene reflujo clínico y por endoscopía. El tratamiento es IBP (ej. omeprazol) a permanencia. Que los síntomas hayan recurrido, solo hace que con mayor razón sea reflujo y se deban reiniciar los IBP.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 38 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Un paciente de 27 años, con historia de pirosis y regurgitación de algunos meses de evolución, siendo diagnosticado de reflujo gastroesofágico. Se indican cambios en los hábitos alimentarios y omeprazol a razón de 20 mg al día y se controla un mes después con endoscopía digestiva alta que demuestra esofagitis distal severa y test de ureasa (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar prokinéticos
B) Agregar antiácidos
C) Duplicar la dosis de omeprazol
D) Erradicar Helicobacter Pilory
E) Tratamiento quirúrgico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un RGE grave, en un paciente joven, con respuesta incompleta al omeprazol: Es la principal indicación de cirugía, además del esófago de Barret.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 145 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Una paciente de 34 años consulta por disfonía intermitente, principalmente en la mañana, asociada a carraspera. Su examen físico es normal. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A) Azitromicina oral 500 mg/día por 5 días
B) Prednisona oral 20 mg/día
C) Lanzoprazol oral 20 mg/día por 30 días
D) Amoxicilina oral 500 mg/8 horas por 7 días
E) Ibuprofeno 400 mg/8 horas por 7 días

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta rara, pero se trata de un caso de RGE con síntomas atípicos: disfonía matinal. Otros son caries y asma de difícil manejo.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 41 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Una paciente de 59 años inicia un cuadro de 3 semanas de evolución de pirosis y dolor epigástrico, con episodios diurnos y nocturnos. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar endoscopía digestiva alta
B) Solicitar ecografía abdominal
C) Solicitar TAC de abdomen
D) Iniciar omeprazol oral
E) Medir pH esofágico de 24 horas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Medir pH esofágico de 24 horas** (opción **E**). La diarrea aguda pediátrica es mayoritariamente viral (rotavirus); el manejo fundamental es la hidratación según grado de deshidratación De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 65 · 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Un paciente de 36 años consulta por disfonía de varios meses de evolución, de predominio matinal, que mejora durante el día y que se intercala con periodos de tiempo, en los cuales no tiene alteraciones de la voz. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar esomeprazol
B) Iniciar prednisona oral
C) Solicitar endoscopía digestiva alta
D) Solicitar radiografías contrastadas de esófago-estómago-duodeno
E) Solicitar TAC de cuello

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una disfonía por reflujo (mayor en la mañana). Se puede hacer una prueba terapéutica, aunque lo mejor suele ser solicitar una pH-metría para confirmar el diagnóstico.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 26 · 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Un paciente de 58 años, desde hace 3 años, presenta pirosis y regurgitación frecuentes. Su examen físico no aporta mayor información. Se realiza una endoscopía digestiva alta, que muestra mucosa esofágica con esofagitis distal moderada, la línea Z a 28 cm de la arcada dentaria y la impresión diafragmática a 37 cm de la arcada dentaria y mucosa gástrica sin alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hernia hiatal directa
B) Esófago de Barret
C) Infección por Helicobacter pylori
D) Acalasia esofágica
E) Divertículo esofágico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hernia hiatal directa** (opción **A**). Clase sobre diarrea aguda y crónica en pediatría. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 65 · 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Paciente con pirosis y regurgitación, EDA muestra línea Z a 20 cm e impresión diafragmática a 30 cm. ¿Diagnóstico más probable?

A) Esófago de Barrett
B) Hernia hiatal por deslizamiento (tipo I)
C) Hernia hiatal paraesofágica (tipo II)
D) Acalasia
E) Esofagitis erosiva grado B

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hernia hiatal por deslizamiento (tipo I)** (opción **B**). Hernia hiatal por deslizamiento (tipo I). Clase sobre diarrea aguda y crónica en pediatría. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 120 · 1.06.1.027 · Reflujo gastroesofágico

Un paciente de 26 años consulta por pirosis y regurgitación de varios meses de evolución. Su examen físico no aporta mayor información. Se realiza una endoscopía digestiva alta que muestra mucosa de aspecto normal, línea Z a 28 cm de la arcada dentaria e impresión hiatal diafragmática a 37 cm de la arcada dentaria. El diagnóstico más probable es:

A) Acalasia esofágica
B) Hernia hiatal directa
C) Hernia paraesofágica
D) Esófago de Barret
E) Divertículo esofágico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene la línea Z más arriba que el diafragma, por lo que hay una hernia por deslizamiento, también llamada hernia tipo l, hernia esofagogástrica o hernia por deslizamiento. Si bien puede facilitar el RGE, su manejo es la observación y tratar el RGE si es que se produce. El otro tipo de hernia hiatal es la indirecta o tipo Il o paraesofágica, que sí se opera, al igual que la mayoría de las hernias, ya que tiene riesgo de complicaciones.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 96 · 1.06.4.015 · Colangiografía por resonan

Un paciente de 35 años, colecistectomizado hace 6 meses por vía laparoscópica, consulta por dolor epigástrico, progresivo, que inició hace 24 horas y que se ha asociado a ictericia y acolia. Al examen físico está afebril, con FC: 80x' y PA: 120/76 mmHg y se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan pruebas hepáticas que muestran GOT: 45 UI/L, GPT: 52 UI/L, FA: 430 UI/L, GGT: 566 UI/L, bilirrubina de 6,4 mg/dl y TP: 88%. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico?

A) TAC de abdomen
B) Ecografía abdominal
C) Resonancia magnética nuclear abdominal
D) Colangioresonancia
E) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil y discutible. El diagnóstico más probable es una coledocolitiasis. Suele iniciarse con ecografía. De elección para el diagnóstico la colangioRMN (por eso la dejamos como respuesta correcta). Sirve, además, como examen no solo diagnóstico, sino terapéutico, la CPRE (la que se pide si 1. la ecografía ve cálculos en el colédoco [no en la vesícula], 2. la CPRE confirma el diagnóstico o 3. la clínica es de colangitis).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 73 1.06.4.015 · Colangiografía por resonan

Un paciente de 40 años, con antecedente de colecistectomía laparoscópica hace un año por colelitiasis, consulta por cuadro de 24 horas de dolor abdominal asociado a vó- mitos e ictericia. Su perfil hepático muestra GOT: 42UI/L, FA: 450mg/dL, bilirrubina total es de 10,3mg/dL, con bilirrubina directa de 9,5 mg/dL. Se realiza una ecografía abdomi- nal que muestra dilatación de la vía biliar principal, sin visualización de cálculos. El examen de elección para continuar el estudio es:

A) Colangioresonancia
B) Colangiografía endoscópica
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Exploración quirúrgica
E) Marcadores tumorales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

A, B? La sospecha es una coledocolitiasis residual y la verdad es que no existe una única forma de enfrentarla. La evidencia no es clara y las recomendaciones son muy variables. Por un lado, la conlangioresonancia da mucha información y en el algún mo- mento, la sociedad chilena de cirugía la recomendó antes que la CPRE, por tener menos efectos adversos y poder diferencias aquellos pacientes que se benefician de la CPRE de aquellos que requieren otro tratamiento. Sin embargo para muchos, la CPRE sigue sien- do el examen de elección, por ser diagnóstico y terapéutico. No deberían poner ambas opciones.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 110 1.06.1.010 · Diarrea asociada a antibió

Puérpera de 5 días con deposiciones líquidas múltiples con moco y sangre, calambres abdominales y fiebre 38.5°C. Hospitalizada durante el parto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infección por Clostridioides difficile
B) Gastroenteritis viral
C) Colitis ulcerosa de novo
D) Salmonelosis
E) Síndrome de intestino irritable postinfeccioso

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diarrea con sangre + fiebre en paciente hospitalizada reciente + puérpera (exposición a antibióticos perinatales) = infección por C. difficile. Diagnóstico: toxina A/B en deposiciones. Tratamiento: vancomicina oral.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 107 1.06.1.010 · Diarrea asociada a antibió

Una paciente de 31 años, con antecedente de parto hace 3 meses, consulta por un cuadro de diarrea de dos meses de evolución de tipo acuoso que ha empeorado en los últimos días, no ha presentado fiebre ni sangre en sus deposiciones. En su examen físi- co presenta dolor difuso a la palpación abdominal y meteorismo. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad celiaca
B) Colitis ulcerosa
C) Diarrea nosocomial
D) Enteroparasitosis
E) Diarrea crónica funcional

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

En el parto recibió antibióticos y la diarrea por clostridium puede aparecer hasta 2 meses después de haber terminado el uso de antibióticos. Eso sí, se debe ser cuidado- so, porque hay quienes definen a la diarrea nosocomial en términos más estrictos, que no calzan con el del caso clínico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 56 1.06.1.011 · Diarrea crónica

Una paciente de 53 años presenta cambio del hábito intestinal, caracterizado por diarrea acuosa, de 3 meses de evolución, asociada a dolor abdominal ocasional. Además, ha bajado 4 kilogramos de peso, desde el inicio de los síntomas. Se realizan exámenes de sangre, entre los que destacan hematocrito: 30%, Hemoglobina: 9,7 g/dl y VCM: 69 fl, albúmina: 2,8 g/dl y GOT: 40 UI/L. Tiene antecedente de un hijo con enfermedad celíaca. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en esta paciente?

A) Endoscopía digestiva alta, con biopsia de duodeno
B) Ecografía abdominal
C) Colonoscopía
D) Detección de anticuerpos antitransglutaminasa en sangre
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Colonoscopía). Lo primero a descartar es el cáncer de colon (después la enfermedad celíaca).. La glomerulonefritis se diagnostica con sedimento urinario que muestra hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos/eritrocitarios. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 157 1.06.1.008 · Trastornos digestivos func

Una paciente de 45 años consulta por dolor abdominal de 4 meses de evolución, caracterizado por malestar abdominal difuso con exacerbaciones cólicas, que ha tenido una intensidad variable y que se asocia a deposiciones de consistencia dura, 8po Bristol 2, que se presentan cada 4 a 5 días, tras las cuales el dolor disminuye considerablemente. Sin embargo, también ha presentado episodios de diarrea de manera esporádica. Su examen Fsico muestra abdomen blando, sensible, sin masas, visceromegalia ni signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de intes2no irritable con predominio de cons2pación
B) Enfermedad celíaca
C) Coli2s ulcerosa
D) Cáncer de colon
E) Cons2pación funcional

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El síndrome de intestino irritable SII) se caracteriza por dolor abdominal, que suele disminuir con la evacuación y cambios en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. No Gene signos de alarma que hagan pensar en patología orgánica. Aunque su consGpación es funcional, el diagnóstico “consGpación funcional” se uGliza en caso en que no Gene dolor abdominal y, por tanto, no cumple con los criterios de SII.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 19 1.06.1.008 · Trastornos digestivos func

Una paciente de 27 años hace 3 años se realiza una gastrectomía longitudinal y hace 6 meses se realiza una colecistectomía laparoscópica. Luego de eso ha presentado dolor epigástrico tipo cólico, intenso, intermitente, postprandial, que en ocasiones la despiertan en la madrugada. Su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer de vesícula
B) Coledocolitiasis
C) Úlcera péptica
D) Obstrucción intestinal por bridas
E) Síndrome de dumping

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien, en estricto rigor, lo que tiene es un síndrome postcolecistectomía, la E es la única opción aceptable y la colecistectomía puede empeorarlo (síntomas disautonómicos y digestivos postingesta de alimentos de rápida absorción).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 83 1.06.1.020 · Hepatitis agudas B, C, por

Una paciente de 20 años, en tratamiento con isotretinoína, desde hace 10 días, por acné, consulta por dolor abdominal, asociada a malestar general y astenia, a lo que se ha agregado ictericia y orinas oscuras. En su examen físico se aprecia ictericia de piel y mucosas y su abdomen se palpa bando, doloroso en epigastrio e hipocondrio, con hígado palpable 3 cm por debajo del reborde costal. Sus pruebas hepáticas resultan GOT: 328 UI/L, GPT: 459 UI/L, bilirrubina: 1,8 mg/dl, FA: 80 UI/L, GGT: 92 UI/L, protrombinemia: 80%. Además, se solicita serología que muestra IgG(+)VHA, IgM(-)VHA, Antígeno VHBs(-), Anticuerpos totales antiHBVc(+). Anticuerpos anti-VHC y marcadores de autoinmunidad pendientes. El diagnóstico más probable es:

A) Hepatitis A
B) Hepatitis B
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por drogas
E) Hepatitis autoinmune

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una hepatitis, que, por descarte, es farmacológica (por la isotretinoína). No es VHA, porque la IgM está negativa. No es VHB porque el antígeno de superficie está negativo (no aporta mayor información los anticuerpos totales anticore). No es VHC, porque los anticuerpos totales anti VHC está negativos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 119 1.06.4.012 · Estudio de marcadores vira

Un paciente de 50 años asintomático se realiza pruebas hepáticas como parte de un chequeo médico, que muestran una SGOT: 332 UI/L y SGPT: 210 UI/L, con bilirrubina de 1,5 mg/dl. No refiere hábitos tóxicos. Como antecedente, tuvo un hemoperitoneo traumático el año 1992, que requirió de transfusiones. ¿Qué examen se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica?

A) Antígeno de superficie
B) IgM para VHA
C) Test de HOMA
D) TAC de abdomen
E) Anticuerpos totales contra VHC

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una hepatitis. El antecedente de transfusiones hace pensar en VHC, que se estudia con anticuerpos totales anti VHC. En la vida real se pedirían más exámenes.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 146 1.06.4.012 · Estudio de marcadores vira

Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, asociado a malestar general, astenia y náuseas, a lo que recientemente se agrega ictericia. Al examen físico, destaca ictericia de escleras, pulso regular a 76x', PA: 110/70 mmHg, abdomen blando, depresible, pero con dolor a la palpación del epigastro e hipocondrio derecho, sin visceromegalia ni signos peritoneales. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran tiempo de protrombinemia: 70%, SGOT: 512 UI/L, SGPT: 356 UI/L, FA: 230 UI/l, GGT: 120 UI/L, albúmina: 3,8 g/dl, bilirrubina total: 4 mg/dl, con 35% de bilirrubina directa. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) TAC abdominal
C) Endoscopía digestiva alta
D) Colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
E) Serología para virus hepatitis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Serología para virus hepatitis** (opción **E**). Bilirrubina >1.1 es alta; ictericia clínica aparece sobre 2.5-3 mg/dL De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 180 1.06.1.003 · Cáncer de vesícula y vías

Una paciente de 91 años, diabética, con antecedente de cólicos biliares a repetición, consulta por astenia, decaimiento, ictericia marcada y orinas oscuras, de 3 semanas de evolución, asociadas a dolor epigástrico moderado. Al examen físico, se aprecia ictericia de piel y mucosas y se palpa una masa en el hipocondrio derecho. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran SGOT: 60 UI/L, SGPT: 56 UI/L, GGT: 570 UI/L, FA: 755 UI/L, bilirrubina total: 21 mg/dl, bilirrubina directa: 19 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer de la cabeza de páncreas
B) Cáncer de vesícula
C) Colangiocarcinoma
D) Hepatocarcinoma
E) Cáncer de la ampolla de Vater

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las pruebas hepáticas muestras una colestasia clara y la clínica también. La colestasia silente (sin dolor) o con escaso dolor suele ser por cáncer (cualquier a de los de las opciones). De todos modos, orienta a cáncer de vesícula el hecho de que sea mujer y, además, el antecedente de cólicos biliares (ya que la colelitiasis es el factor de riesgo más importante). El cáncer de cabeza de páncreas suele preguntarse en diabéticos o fumadores y suele mostrarse la dilatación del colédoco en la ecografía.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 118 · 1.06.1.003 · Cáncer de vesícula y vías

Una paciente de 82 años con antecedente de colecistectomía hace 5 años, consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por ictericia y coluria, asociado a decaimiento. Niega dolor, pero refiere que ha bajado de peso en los últimos meses. Sus signos vitales son normales y se observa en buen estado general, orientada e hidratada, con ictericia de piel y escleras. Al examen abdominal no se palpan masas ni signos peritoneales. Los exámenes de laboratorio revelan fosfatasas alcalinas: 422 UI/L, GGT: 322 UI/L, GOT: 110 UI/L, GPT: 75 UI/L, protrombinemia: 90% y albúmina sérica: 3,1 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer de páncreas
B) Coledocolitiasis residual
C) Cáncer de duodeno
D) Cáncer de la vía biliar
E) Colangitis esclerosante primaria

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Sospecha de Cáncer de Vía Biliar: La sospecha clínica en este paciente es de un cáncer que obstruye la vía biliar, considerando su edad y la presencia de ictericia sin dolor. El antecedente de colecistectomía previa hace poco probable un cáncer de vesícula biliar, pero aún puede tener uno de vía biliar o colangiocarcinoma.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 27 · 1.06.1.003 · Cáncer de vesícula y vías

Una paciente de 35 años, presenta dolor en el hipocondrio izquierdo, asociado a meteorismo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que visualiza un pólipo en el fondo vesicular, de 4 mm de diámetro, homogéneo y se observa la vía biliar de 5 mm de diámetro. La conducta más adecuada es:

A) Control ecográfico en 6 meses
B) Solicitar una TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar una resonancia magnética nuclear abdominal
D) Realizar biopsia del pólipo
E) Realizar colecistectomía laparoscópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene clínica de un trastorno digestivo funcional (ej. Síndrome de intestino irritable) y los hallazgos en la ecografía no muestran sino un pólipo de características benignas (son malignos y hay que sacarlos si: miden más de 1 cm, tienen cálculos asociados, tienes aspecto invasor o heterogéneo). La vía biliar normal es hasta 7 mm.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 178 · 1.06.4.014 · Determinación toxina C dif

Un paciente de 65 años estuvo hospitalizado por una neumonía y, al cuarto día después del alta, inicia dolor abdominal, asociado a diarrea acuosa, con malestar general e incontinencia fecal, que ha ido empeorando, en los 7 días siguientes. Al examen físico tiene abdomen distendido, doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos +++. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio inicial de este paciente?

A) Colonoscopía
B) Coprocultivo
C) Recuento de leucocitos fecales
D) Parasitológico en deposiciones
E) Toxinas A y B para

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una diarrea asociada a antibióticos (seguramente indicados para tratar la neumonía), por lo que se debe estudiar la presencia de C. difficile con PCR o con toxinas A y B en deposiciones. Si no están disponibles, se puede proceder a tratar con metronidazol oral.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 124 · 1.06.4.006 · Ecotomografía abdominal

Un paciente de 54 años consulta por dolor abdominal epigástrico intenso, tipo cólico, asociado a náuseas de 6 horas de evolución, por lo que consulta en el servicio de urgencia. Recibe hidratación y analgésicos por vía endovenosa, con respuesta parcial, por lo que es dado de alta. Al día siguiente evoluciona con aumento del dolor, agregándose calofríos y vómitos alimentarios. Al examen físico, tiene FC: 90x', PA: 120/80 mmHg, Tº: 38ºC y en el examen abdominal presenta dolor intenso a la palpación del abdomen superior, en especial en el hipocondrio derecho. Sus exámenes muestran hematocrito: 43%, blancos: 13.000 por mm3, GOT: 56 UI/L, bilirrubina: 1,1 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) TAC de abdomen
B) Endoscopía digestiva alta
C) Colangioresonancia
D) Ecografía abdominal
E) Radiografía de abdomen simple

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Ecografía abdominal** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (TAC de abdomen, Endoscopía digestiva alta) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 161 · 1.06.3.005 · Antiinflamatorios no ester

Una paciente de 65 años, con antecedente de haber sido tratada de una úlcera duodenal hace 20 años, y de un infarto agudo al miocardio hace un año, utilizando aspirina 100 mg al día desde entonces, sufre un esguince de tobillo, por lo que se indica analgesia con diclofenco 100 mg cada 12 horas. En los días siguientes evoluciona con malestar general que va agravándose y se agrega disnea. Al examen físico presenta palidez mucocutánea, FC: 110x', PA: 110/66 mmHg, examen pulmonar normal y examen cardíaco que solo muestra taquicardia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,5 g/dl, hematocrito: 23% VCM: 58 ft, plaquetas: 370.000 por mm3, ferritina: 12 ng/ml. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, sin signos actuales de isquemia. ¿Cuál es el examen para proseguir el estudio etiológico?

A) Prueba de antígeno en deposiciones para Helicobacter pylori
B) Niveles de vitamina B12
C) Biopsia de médula ósea
D) Endoscopía digestiva alta
E) Test de sangre oculta en deposiciones

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Endoscopía digestiva alta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Prueba de antígeno en deposiciones para Helic, Niveles de vitamina B12) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 117 1.06.3.005 · Antiinflamatorios no ester

Un paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, presenta dolor abdominal recurrente intenso que aparece 30 minutos después de comer y cede con el ayuno. Además, refiere baja de peso de 10 kg en los úl8mos meses y deposiciones blandas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Cáncer gástrico
B) Cáncer de páncreas
C) Úlcera gastroduodenal
D) Angina mesentérica
E) Coli2s isquémica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

En una angina mesentérica clásica, con dolor postprandial y baja de peso, en alguien con factores de riesgo cardiovascular. La pancreaGGs crónica puede tener un cuadro clínico similar, pero suele ser en pacientes con alcoholismo, en lugar de factores de riesgo cardiovascular.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 100 1.06.4.005 · TAC abdominal

Hombre de 62 años con pérdida de peso de 10 kg en 3 meses, ictericia progresiva, coluria y heces acólicas. Ecografía: dilatación de vía biliar intra y extrahepática, páncreas no visualizado. ¿Cuál es el examen siguiente más apropiado?

A) Ecografía de control en 1 mes
B) Radiografía de abdomen
C) AngioTAC de páncreas y vía biliar
D) Endoscopía digestiva alta
E) Resonancia magnética de columna

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ictericia obstructiva con dilatación biliar y sospecha de tumor pancreático: el siguiente examen es AngioTAC de páncreas (protocolo páncreas) o CRMN para caracterizar la lesión, evaluar extensión vascular y ganglionar para etapificación y decisión quirúrgica.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 72 1.06.4.005 · TAC abdominal

Paciente con dolor en FII, febril y signo de Blumberg en FII. ¿Cuál es el examen de elección?

A) Ecografía abdominal
B) Colonoscopía
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Enema baritado
E) Laparoscopia diagnóstica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (TAC de abdomen y pelvis). TAC de abdomen y pelvis. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 5 1.06.4.005 · TAC abdominal

Hombre de 65 años con dolor abdominal postprandial, pérdida de peso de 6 kg y soplo abdominal. Antecedente de tabaquismo y cardiopatía coronaria. Se sospecha isquemia mesentérica crónica (angina intestinal) en etapa estable. ¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico?

A) AngioTAC de vasos mesentéricos
B) Resonancia magnética
C) Angiografía convencional
D) Ecografía Doppler mesentérica
E) Radiografía simple de abdomen

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

AngioTAC de vasos mesentéricos es el estudio inicial de elección para isquemia mesentérica crónica estable: no invasivo, permite visualizar el tronco celíaco, AMS y AMI. La angiografía convencional se reserva si se planifica revascularización.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 74 1.06.4.007 · Endoscopía digestiva alta

Paciente con diarrea disentérica y baja de peso. ¿Cuál es el examen de elección?

A) Coprocultivo y coproparasitológico
B) TAC de abdomen con contraste
C) Tránsito de intestino delgado
D) Colonoscopía con biopsias
E) Cápsula endoscópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Colonoscopía con biopsias). Colonoscopía con biopsias. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 50 1.06.2.002 · Afagia aguda

Disfagia a nivel de xifoides luego de comer pollo, que no permitía el paso de agua. Conducta:

A) EDA
B) Radiografía
C) Nasolaringoscopia
D) Manometría esofágica
E) Derrame pleural

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **EDA** (opción **A**). Trauma torácico (cerrado y arma blanca): clínica + radiografía de tórax con manejo de complicaciones De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 102 1.06.3.006 · Esteatopatía no alcohólica

Mujer obesa 2-3 copas de vino sólo el fin de semana en tratamiento con estatinas, transaminasas con doble del valor normal:

A) esteatohepatitis no alcoholica
B) esteatohepatitis alcohólica
C) hepatitis por fármacos
D) hepatitis por VHC
E) Hepatitis AI

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **esteatohepatitis no alcoholica** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 26 1.06.2.008 · Hepatitis aguda A complica

Una paciente de 30 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por astenia, fiebre, malestar general y dolor epigástrico. Hace dos días se agregó ictericia de piel y escleras el día de hoy presentó orinas oscuras. Al examen físico tiene FC: 96x', PA: 100/60 mmHg, con ictericia franca en escleras y piel, sin alteraciones en el nivel de conciencia. En el examen abdominal se observa dolor a la palpación epigástrica y del hipocondrio derecho, sin signos peritoneales ni visceromegalia; los ruidos hidroaéreos están conservados. Se solicitan exámenes, que muestran GOT: 2.640 UI/L, GPT: 2.860 UI/L, GGT: 180 UI/L, FA: 412 UI/L, protrombinemia: 52%, bilirrubina total: 9,2 mg/dl, fracción directa: 6,6 mg/dl, albúmina plasmática: 3,4 g/dl. Se solicita IgM para virus hepatitis A, que resulta 5,5 UI (VN: menor a 0,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente?

A) Dieta blanda y reposo en domicilio
B) Hospitalizar
C) Solicitar ecografía abdominal y controlar ambulatoriamente
D) Solicitar una colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
E) Indicar N-acetil-cisteína oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hepatitis aguda grave: El cuadro clínico es compatible con una hepatitis aguda, confirmada por las pruebas hepáticas que muestran una elevación significativa de las transaminasas. La IgM positiva para el virus de la hepatitis A confirma la etiología. La gravedad del cuadro radica en la disminución de la protrombinemia, lo que requiere manejo hospitalario. Aunque aún no cumple con los criterios de hepatitis fulminante (no hay compromiso de la conciencia), la caída de la protrombinemia aumenta el riesgo de evolucionar hacia ella.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 140 1.06.1.025 · Pancreatitis crónica

Hombre de 55 años, alcohólico crónico y fumador, con dolor epigástrico que se irradia a la espalda, aparece con la ingesta de alimentos y se calma al inclinarse hacia adelante. Presenta baja de peso de 8 kg. Transaminasas y amilasa levemente elevadas. Radiografía: calcificaciones en epigastrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Úlcera gástrica perforada
B) Obstrucción intestinal
C) Pancreatitis crónica
D) Colecistitis aguda
E) Hepatitis alcohólica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pancreatitis crónica: dolor epigástrico irradiado a la espalda + ingesta de alcohol crónico + posición antiálgica en flexión + baja de peso + CALCIFICACIONES pancreáticas en radiografía = tríada diagnóstica. El dolor mejora en reposo y empeora con la ingesta.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 138 1.06.1.025 · Pancreatitis crónica

Un paciente de 60 años, gran fumador y con antecedentes de consumo excesivo de alcohol, hasta hace 6 meses en que suspendió el cigarrillo y la ingesta de alcohol, consulta por episodios de dolor abdominal epigástrico intenso, asociado a vómitos alimentarios. Refiere también episodios de diarrea abundante, que han ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que muestra hemograma con hematocrito: 39%, blancos: 9.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3; glicemia de ayuno: 122 mg/dL, lipasa plasmática: 210 UI/L, amilasa plasmática: 90 UI/L, fosfatasa alcalina: 210 UI/L, GOT: 32 UI/L, GPT: 40 U/L y GGT: 70 UI/L. Se realiza ecografía abdominal, que se describe como "ventana ecográfica insuficiente por meteorismo". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pancreatitis aguda
B) Colecistitis aguda
C) Cáncer de páncreas
D) Coledocolitiasis
E) Pancreatitis crónica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pancreatitis Crónica: El caso describe una pancreatitis crónica con complicaciones típicas como diabetes (tien glicemia de ayuno alterada y no aún diabetes) y síndrome de mala absorción. Se caracteriza por dolor abdominal, generalmente después de ingerir alimentos o alcohol. La causa más frecuente es el alcoholismo.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 17 1.06.1.028 · Síndrome de malabsorción

Una paciente de 40 años consulta por deposiciones frecuentes y diarrea de 3 meses de evolución. Presenta urgencia defecatoria, especialmente tras ingerir alimentos ricos en grasa, y nota gotas de grasa flotando en el inodoro, luego de defecar. Adicionalmente, refiere baja de peso no cuan8ficada. Su examen Fsico muestra signos vitales normales y su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales ni masas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Insuficiencia pancreá2ca exocrina
C) Sobrecrecimiento bacteriano
D) Coli2s ulcerosa
E) Giardiasis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta discuGble. Tiene un síndrome de malabsorción intestinal, el que Gene muchas causas, sin que sea posible diferenciarlas con la sola clínica. Sin embargo, la presencia de esteatorrea franca y de empeoramiento de la clínica con la ingesta de grasas es lo clásico de la deficiencia de enzimas pancreáticas. La enfermedad celíaca es más frecuente y puede tener esteatorrea, pero suele ser más suGl, predominando la anemia, otros déficits nutricionales y molestias digestivas inespecíficas.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 18 1.06.2.001 · Abdomen agudo

Un paciente presenta diarrea abundante, asociada a malestar general. En su tercer día de evolución, presenta dolor abdominal y distensión abdominal progresiva. Al examen Fsico se observa decaído, en malas condiciones generales, subfebril (37,6 °C), con abdomen distendido y doloroso a la palpación, sin signos peritoneales. Sus signos vitales muestran presión arterial 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca 110 lpm. Se solicita radiograFa de abdomen, que revela dilatación de las asas del colon, alcanzando un diámetro de hasta 10 cm a la altura del ciego. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de Hirschsprung
B) Síndrome de Ogilvie
C) Obstrucción intes2nal
D) Coli2s isquémica
E) Megacolon tóxico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un megacolon tóxico. El diagnóstico se confirma por la tríada de: 1) antecedente de coliGs (diarrea), 2) dilatación colónica >6 cm en radiografía y 3) signos de toxicidad sistémica (hipotensión, taquicardia y fiebre). Es una emergencia médica que requiere descompresión y soporte hemodinámico agresivo.

RESPIRATORIO / NEUMOLOGÍA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 04

127 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

40 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.1.001	Absceso pulmonar	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.003	Asma bronquial leve y moderada	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	12 Q	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.1.004	Bronquiectasias	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.1.006	Bronquitis crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 04 · C.6 (Pág. 16)
1.05.1.007	Cáncer bronquial primario	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.1.009	Daño pulmonar secundario a drogas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 04 · C.9 (Pág. 22)
1.05.1.010	Derrame pleural neoplásico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 04 · 3.1 (Pág. 39)
1.05.1.011	Derrame pleural paraneumónico complicado	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.05.1.012	Derrame pleural paraneumónico simple	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.05.1.015	Embolia pulmonar	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	13 Q	Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62)
1.05.1.017	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13)
1.05.1.018	Enfermedades del intersticio pulmonar	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60)
1.05.1.020	Hidatidosis pulmonar	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 04 · C.20 (Pág. 44)
1.05.1.022	Infecciones de las vías aéreas superiores	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 04 · C.22 (Pág. 48)
1.05.1.026	Neumoconiosis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60)
1.05.1.027	Neumonías adquiridas en la comunidad	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	13 Q	Tomo 04 · 2.1 (Pág. 22)
1.05.1.029	Neumonías en inmunosuprimidos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28)
1.05.1.031	Neumotórax moderado y grande	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 3.3 (Pág. 45)
1.05.1.032	Neumotórax pequeño	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47)
1.05.1.033	Síndrome de apnea del sueño	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 04 · 5.3 (Pág. 77)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.1.035	Tos crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.1.036	Tuberculosis pulmonar	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.1.038	Nódulos pulmonares	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.2.004	Crisis de asma bronquial	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 1.2 (Pág. 7)
1.05.2.005	Embolia pulmonar masiva	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62)
1.05.2.006	Enfermedad bronquial obstructiva crónica descompensada	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 04 · 1.5 (Pág. 15)
1.05.2.008	Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71)
1.05.2.010	Intoxicación por monóxido de carbono	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79)
1.05.3.003	Programa Nacional de Control de TBC	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 2.5 (Pág. 32)
1.05.3.004	Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.4.001	Radiografía de tórax	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.4.002	TAC de tórax	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.4.004	Baciloscopia y cultivo de Koch de expectoración	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.4.007	Citoquímico de líquido pleural	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.4.012	Prueba de provocación bronquial con fármacos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.4.013	Pruebas cutáneas de alergia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.5.002	Biopsia pleural	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.5.005	Fibrobroncoscopia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 04 · 4.1 (Pág. 56)
1.05.5.009	Punción pleural	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.5.012	Ventilación mecánica no invasiva	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 24 1.05.4.012 · Prueba de provocación bron

Paciente de 20 años, con antecedente de rinitis alérgica y usuaria de anticonceptivos orales, con historia de disnea y tos seca al realizar ejercicios, no asociado a otros síntomas. Actualmente asintomática y su examen físico es normal. El examen de elección para el diagnóstico de esta paciente es:

A) Test de esfuerzo
B) Test de metacolina
C) Prick test
D) Espirometría
E) PEF

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por ser un asma sin clínica actual, no servirá ni el PEF ni la espirometría. Esta pregunta también es muy discutible, ya que el diagnóstico de asma es clínico y los demás exámenes solo son de apoyo diagnóstico. Además en la mayoría de los libros, guías y recomendaciones se prefiere hacer espirometría y solo solicitar las demás pruebas ante la duda diagnóstica. Sin embargo, el eunacom ha preguntado esto varias veces y ante un examen totalmente normal y clínica muy leve, la espirometría resulta normal y no sirve. Además el test de metacolina es una espirometría, pero en la cual se nebuliza con dosis crecientes de metacolina, para producir la broncoconstricción y medir la reactividad bronquial.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 163 1.05.4.012 · Prueba de provocación bron

Una paciente de 19 años presenta disnea, asociada a tos y ocasionalmente sibilancias. Refiere que sus síntomas suelen ser más frecuentes e intensos durante la noche. Ha notado aumento en la intensidad y frecuencia de estos síntomas, desde que adoptó un gato hace un mes. Sus signos vitales son normales, satura 98% a FiO2 ambientas y su examen cardiopulmonar es normal. Se solicita una radiografía de tórax, que resulta normal. Se realiza una espirometría basal y postbroncodilatador, que muestra parámetros dentro de la normalidad. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) IgE sérica total
B) TAC de tórax
C) Prueba de provocación bronquial con metacolina
D) Prueba cutánea para alérgenos inhalados
E) Serología para Mycoplasma pneumoniae

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico de Asma: En un paciente con síntomas compatibles con asma pero sin obstrucción en el examen físico ni en la espirometría, la prueba de provocación bronquial con metacolina se utiliza para confirmar el diagnóstico. Un resultado positivo a la prueba apoya el diagnóstico de asma, que es fundamentalmente clínico.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 64 1.05.4.012 · Prueba de provocación bron

Una paciente de 21 años presenta rinorrea, congestión nasal, disnea, tos, con expectoración mucosa y sibilancias, que aparecen luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias, siendo mayores en primavera. Su examen físico tiene frecuencia respiratoria 12x', frecuencia cardíaca 73x', PA: 120/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal. Se solicitar un PEF, que resulta 580 L/min, que equivale al 100% del valor esperado. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en esta paciente?

A) Prick test
B) TAC de tórax
C) Espirometría basal y postbroncodilatador
D) Prueba de eosinófilos nasales
E) Prueba de provocación bronquial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Aunque el diagnóstico de asma es principalmente clínico, tanto la espirometría como la prueba de provocación con metacolina son útiles para apoyar el diagnóstico. La espirometría es de elección en los pacientes con obstrucción clínica y la provocación con metacolina es de elección en los pacientes sin nada de obstrucción basal, como en esta paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 66 1.05.4.012 · Prueba de provocación bron

Una paciente de 21 años presenta rinorrea, congestión nasal, disnea, tos, con expectoración mucosa y sibilancias, que aparecen especialmente luego de realizar ejercicio y durante las infecciones respiratorias, siendo mayores en primavera. Su examen físico tiene frecuencia respiratoria 12x', frecuencia cardíaca 73x', PA: 120/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal. Se solicitar un PEF, que resulta 580 L/min, que equivale al 98% del valor esperado. Se solicita una radiografía, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para proseguir con el estudio en esta paciente?

A) Prick test
B) TAC de tórax
C) Espirometría basal y postbroncodilatador
D) Prueba de eosinófilos nasales
E) Prueba de provocación bronquial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Prueba de provocación bronquial). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Prick test, TAC de tórax) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 49 · 1.05.4.004 · Baciloscopia y cultivo de

Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos ocasiones hemoptóica. Al examen físico destaca sudoroso, frecuencia cardiaca de 60 por minuto, presión arterial de 120/70, examen cardiaco normal y pulmonar con murmullo presente, crepitaciones y sibilancias difusas mayores en ápice izquierdo. El examen más adecuado para el diagnóstico en este caso es:

A) Baciloscopías seriadas
B) Prueba cutánea de tuberculina
C) Radiografía de tórax
D) TAC de tórax multicorte
E) Hemocultivo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Baciloscopías seriadas** (opción **A**). Sospechar una TBC. Se estudia con BK. La Rx hay que pedirla igual, pero BK es la respuesta.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 99 · 1.05.4.004 · Baciloscopia y cultivo de

Un paciente de 70 años, consulta por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por tos con expectoración mucosa que en ocasiones es purulenta y baja de peso, asocia- do a compromiso del estado general, sensación febril ocasional y fatigabilidad. Se le so- licita perfil hemático que muestra hematocrito de 32%, leucocitos 12.000/mm3. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO La conducta más adecuada para proseguir con el estudio es:

A) Realizar broncoscopía
B) Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch
C) Solicitar TAC de tórax
D) Solicitar angioTAC de tórax
E) Solicitar cultivo de expectoración

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar baciloscopías de expectoración con cultivo de Koch** (opción **B**). La sospecha es una tuberculosis, por el tiempo de evolución y por la clínica.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 152 · 1.05.4.004 · Baciloscopia y cultivo de

Un paciente de 42 años, fumador de 2,6 paquetes-año, presenta un cuadro de 3 meses de compromiso del estado general, astenia y baja de peso de 3 kilogramos, asociado a tos y expectoración mucopurulenta, que en ocasiones es hemoptoica. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra zonas de relleno alveolar en el lóbulo superior derecho. ¿Con qué examen(es) se debe proseguir el estudio?

A) Baciloscopías de expectoración y cultivo para mycobacterias
B) Elisa VIH
C) Biopsia pulmonar por videtoracoscopía
D) Lavado bronquioalveolar por broncoscopía
E) TAC de tórax

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una TBC (cuadro subagudo, con compromiso de los lóbulos superiores), por lo que debe estudiarse con baciloscopías y cultivo.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 115 · 1.05.4.004 · Baciloscopia y cultivo de

Paciente con clínica y rayo de TBC, ¿Cual es el primer estudio que se debe realizar?

A) Iniciar tratamiento b. PCR (PCR porque es más sensible que BK y es lo que recomienda la nueva norma de TBC)
C) Baciloscopias por que PCR si era caso sospechoso? si hubiera sido contacto de alguien con TBC, se trata de entrada, pero el solo tenia clinica y rayo, lo que abre la sospecha, y la sospecha se confirma con PCR
C) Hemograma y VHS
D) Ecografía
E) Radiografía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Iniciar tratamiento b. PCR (PCR porque es más sensible que BK y es lo que recomienda la nueva norma de TBC)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 92 · 1.05.4.004 · Baciloscopia y cultivo de

Paciente enflaquecido, febril, con hemoptisis y baciloscopías negativas. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Cultivo en medio Löwenstein-Jensen
B) Broncoscopía con lavado broncoalveolar
C) PCR para Mycobacterium tuberculosis
D) Adenosina deaminasa (ADA) en esputo
E) Biopsia pulmonar por toracoscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (PCR para Mycobacterium tuberculosis). PCR para Mycobacterium tuberculosis. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 64 · 1.05.1.018 · Enfermedades del interstic

Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca acropaquia y al examen pulmonar murmullo pulmonar disminuido bilateral con presencia de crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen en panal de abejas. El diagnóstico más probrable es:

A) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
B) Tuberculosis
C) Enfermedad pulmonar intersticial difusa
D) Cáncer pulmonar
E) Tromboembolismo pulmonar crónico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad pulmonar intersticial difusa** (opción **C**). Es una fibrosis pulmonar.. Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 38 1.05.1.018 · Enfermedades del interstic

Una paciente de 58 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por un cuadro de 2 años de evolución de disnea progresiva, que ha aumentado en el último tiempo, volviéndose de pequeños esfuerzos. Además, refiere expectoración mucosa, que suele ser mayor en las mañanas. Evita realizar actividad física, transportar carga y subir escaleras, debido a la disnea. Como antecedente, fumó 4 cigarrillos al día, hasta hace un año. En el examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 86 lpm, presión arterial: 120/70 mmHg, frecuencia respiratoria basal: 15 rpm, saturación arterial de oxígeno: 93% a FiO2 ambiental. La auscultación cardíaca muestra ritmo regular en dos tiempos, sin presencia de soplos y la auscultación pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, disminuido de manera global, con presencia de crepitaciones bilaterales. Además, tiene hipocratismo digital. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Asma alérgica
B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C) Bronquitis crónica por cigarrillo
D) Fibrosis pulmonar idiopática
E) Insuficiencia cardíaca congestiva

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fibrosis Pulmonar Idiopática: Tanto la historia clínica como la radiografía son compatibles con una fibrosis pulmonar idiopática.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 98 1.05.1.018 · Enfermedades del interstic

Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida y fumador de 5 paquetes año, consulta por un cuadro de disnea de esfuerzos de 2 años de evolución, que ha progresado desde entonces. Por ello, en la actualidad, evita subir escaleras y cargar cosas pesadas. Al examen físico se aprecian acropaquías y su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar simétrico, con crepitaciones gruesas bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Foto 11 (https://radiopaedia.org/cases/XXXXXXXXXXXXX-2). El diagnóstico más probable es:

A) Neumoconiosis
B) Cáncer bronquioloalveolar
C) Bronquiectasias
D) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
E) Fibrosis pulmonar idiopática

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fibrosis pulmonar idiopática** (opción **E**). Tanto por la clínica, como por la radiografía es una fibrosis pulmonar clásica.. Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 80 1.05.1.031 · Neumotórax moderado y gran

Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

A) Angina inestable
B) Tromboembolismo pulmonar
C) Neumotorax espontáneo
D) Perforación esofágica
E) Contractura muscular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Neumotorax espontáneo** (opción **C**). Clínica muy sugerente de neumotórax. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 140 1.05.2.008 · Insuficiencia respiratoria

Un paciente presenta una neumonía, con dificultad respiratoria, taquipnea, fiebre y desaturación arterial. Satura 75% a FiO2 ambiental y tiene gases arteriales, con una presión arterial de O2 de 54 mmHg y presión de CO2 de 32 mmHg. ¿Cómo debe administrarse el oxígeno a este paciente?

A) Por naricera a 0,5 litros por minuto
B) Por naricera a 2 litros por minuto
C) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 24%
D) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 40%
E) Por ventilación mecánica invasiva

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hay evidencia de baja calidad y reciente, muy discutida, que dicen que la ventilación mecánica invasiva tendría mejores resultados en mortalidad y en tiempo de hospitalización, que la oxigenoterapia por mascarilla. Pregunta muy discutible, porque en la vida real, se evaluará primero la respuesta al oxígeno y se irá viendo cuánto necesita para saturar adecuadamente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 95 1.05.2.008 · Insuficiencia respiratoria

Paciente de 55 años, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, es derivado desde servicio de urgencia rural por aumento de su disnea basal, asociado a sensación febril y luego confusión, al ingreso en nuestro centro se solicitan gases arteriales que muestran pH 7.3, PaCO2 80, PaO2 86 con FiO2 al 100%. En su examen físico destaca sopor superficial, murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, con sibilancias difusas y crepitaciones en base pulmonar izquierda. La medida más adecuada en este momento es:

A) Administrar hidrocortisona en bolo
B) Nebulizar con salbutamol
C) Administrar ceftriaxona
D) Intubar e iniciar ventilación mecánica
E) Disminuir el aporte de oxígeno a 24%

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una encefalopatía hipercárbica. Se va a VMI. El CO2 mayor a 65 también es indicación de ventilación mecánica. El BiPAP (VMNI) es una buena opción, pero si está encefalópata, se prefiere la VMI

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 134 · 1.05.2.008 · Insuficiencia respiratoria

Paciente joven hiperventilando saturando 75% a. Venturi al 40 %

B) Venturi al 24% c. Ventilación mecánica invasiva
D) Naricera flujo 0.2 ml/kg
E) Naricera flujo 2 ml/kg
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Venturi al 24% c. Ventilación mecánica invasiva). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 127 · 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Una paciente de 45 años, hipertensa, presenta un cuadro de 4 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,8°C, mialgias, cefalea y tos con expectoración mucopuruleta. Al examen físico tiene FR: 13 lpm, FC: 80x'. PA: 120/80 mmHg, examen pulmonar con crépitos en la base izquierda, matidez y aumento de la trasmisión de las vibraciones vocales en la zona. Examen cardíaco normal. Satura 98% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.learningradiology.com ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Oseltamivir
B) Levofloxacino
C) Ceftriaxona
D) Amoxicilina
E) Claritromicina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tienen una neumonía típica (con condensación del lóbulo inferior izquierdo), adquirida en la comunidad, sin criterios de hospitalización y en un menor de 65 años, sin antecedentes relevantes (la HTA no agrava las neumonías, salvo las por covid-19), por lo que se debe tratar con amoxicilina sola.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 15 · 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un paciente de 21 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 120/80 mmHg, FR: 17x' y en la auscultación pulmonar se escuchan crepitaciones en la mitad inferior del campo pulmonar derecho. Satura 93% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía lateral de tórax con condensación del lóbulo inferior). ¿Cuál es el tratamiento antibiótico más adecuado?

A) Claritromicina
B) Cefadroxilo
C) Clindamicina
D) Cloxacilina
E) Ciprofloxacino

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo más correcto era dejar amoxicilina, pero de las opciones, el macrólido era la mejor opción, para una NAC de bajo riesgo.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 52 · 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un paciente con antecedente de EPOC, fumador de 25 paquetes año, consulta por cuadro de tres días de evolución de exacerbación de su disnea basal y expectoración mucosa, asociado a sensación febril y hace un día se agrega dolor tipo puntada de cos- tado. Al examen se aprecia frecuencia respiratoria de 21 por minuto, frecuencia cardia- ca de 92 por minuto, temperatura de 38,1°C. Al examen pulmonar presenta crepitacio- nes de la cara lateral del hemitórax derecho, asociado a matidez a la percusión. Se soli- cita una radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO El diagnóstico más probable:

A) Tuberculosis
B) Derrame pleural
C) Neumonía
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Cáncer bronquial

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Neumonía** (opción **C**). Tanto la clínica, como la radiografía apuntaban a NAC.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 132 · 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

IMAGEN: Paciente 66 años con neumonía (clínica e imágen de neumonía monolobar) saturando 94% ¿Cual es el tratamiento?:

A) Ceftriaxona b. Amoxicilina con Ac. clavulánico
B) Derrame pleural
C) Neumotórax
D) Neumonía
E) Atelectasia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ceftriaxona b. Amoxicilina con Ac. clavulánico** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 100 · 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Una mujer de 63 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril y amlodipino, consulta por tos, con expectoración mucopurulenta, de 3 días de evolución. Además, presenta fiebre, malestar general y dolor torácico con la inspiración máxima. Al examen físico, se constata T°: 38 °C, PA: 120/80 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 15 rpm, saturación de oxígeno: 97% y en el examen cardiopulmonar destacan crepitaciones localizados en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Foto 12 (http://elesfenoides.blogspot.com/2014/07/XXXXXXXXXX-imagenes-1.html) ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amoxicilina con ácido clavulánico
B) Ceftriaxona
C) Levofloxacino
D) Clindamicina
E) Azitromicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una neumonía del lóbulo superior derecho. En estricto rigor, se puede tratar con amoxicilina, ya que no tiene indicación de ácido clavulánico. Pero de las opciones, la mejor era la A.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 107 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Paciente de 23 años, sin antecedentes, con cuadro de 2 semanas de rinorrea y coriza, que durante los últimos dos días se asocia a compromiso del estado general, sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta signos vitales dentro de rangos normales, murmullo pulmonar presente en ambos campos pulmonares asociado a crepitaciones en base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra infiltrado intersticial en base derecha. El tratamiento de elección de esta patología es:

A) Claritromicina
B) Amoxicilina-ácido clavulánico
C) Clindamicina
D) Ceftriaxona
E) Moxifloxacino

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por llevar dos semanas, sospechar mycoplasma. También por el compromiso intersticial. El moxifloxacino sí lo cubre, pero su espectro es muy amplio: cubre también anaerobios. Levofloxacino sí habría sido una respuesta correcta. Todos los macrólidos lo cubren bien y son de elección en los niños, que no pueden usar quinolonas y también en los adulto, en particular la azitromicina, que se toma por menos tiempo.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 138 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Hombre de 75 años con neumonía adquirida en la comunidad. Sin hospitalización reciente ni antibióticos en los últimos 3 meses. Sin alergias. ¿Cuál es el antibiótico de primera línea más adecuado?

A) Amoxicilina-clavulánico oral
B) Ciprofloxacino oral
C) Clindamicina oral
D) Cefalexina oral
E) Azitromicina oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

NAC en adulto mayor: mayor riesgo de flora gram negativa, anaerobios y bacterias atípicas. Amoxicilina-clavulánico oral (875/125 mg c/12h) ofrece cobertura ampliada vs amoxicilina sola. En adulto mayor se prefiere sobre amoxicilina sola o macrólidos en monoterapia.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 153 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un adolescente de 17 años presenta un cuadro de 5 días de evolución de tos con expectoración mucosa, al que se le ha agregado fiebre hasta 37,6ºC. Al examen físico está en buenas condiciones, con FR: 15x', saturación oxígeno: 95% y examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, auscultándose crepitaciones y sibilancias bilaterales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Mycoplasma pneumoniae
C) Chlamydia trachomatis
D) Virus influenza
E) Pneumocystis jiroveci

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Que tenga afectación bilateral con crépitos y sibilancias sugiere una neumonía atípica, por Mycoplasma penumoniae, aunque lleve solo 5 días de síntomas (suelen ser cuadros más arrastrados que inician con síntomas respiratorios altos).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 139 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un paciente de 60 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos, asociada a expectoración mucopurulenta. Evoluciona con dificultad respiratoria, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen físico tiene FC: 113x', PA: 100/60 mmHg, FR: 33x' y al examen pulmonar presenta crepitaciones inspiratorias, en el hemicampo pulmonar derecho. La radiografía de tórax muestra condensación en los lóbulos medio e inferior derecho y satura 83%, con FiO2 ambiental, que sube a 90%, con oxígeno al 40%, por mascarilla de recirculación. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección para este paciente?

A) Cefepime más amykacina
B) Ceftriaxona más clindamicina
C) Cloxacilina más metronidazol
D) Cefotaximo más moxifloxacino
E) Piperacilina más tazobactam

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una neumonía grave, que requiere tratamiento en UCI y ventilación mecánica (insuficiencia respiratoria grave). De los tratamientos, lo más adecuado es cefotaximo o ceftriaxona, más un mácrólido o una quinolona respiratoria.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 105 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un paciente con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta un cuadro de 3 días de evolución, de fiebre hasta 38,9°C, asociada a malestar general, tos, expectoración mucopurulenta y aumento de la disnea. Al examen físico se observa con apremio respiratorio de reposo y se auscultan sibilancias difusas, más crepitaciones en la zona posterior del lóbulo inferior derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación. ¿Qué antibiótico es el más adecuado para el tratamiento de este paciente?

A) Amoxicilina
B) Claritromicina
C) Clindamicina
D) Cefotaximo
E) Azitromicina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una neumonía, en contexto de EPOC. En el cuadro clínico no queda del todo claro que requiera hospitalizarse, como para recibir cefotaximo o ceftriaxona (misma cobertura) o si solo requiere tratamiento ambulatorio (con amoxicilina clavulánico, dado que el antecedente de EPOC obliga a cubrir Haemophilus influenzae, lo que también se podría lograr con macrólidos). El apremio respiratorio hace que probablemente la respuesta correcta sea cefotaximo. Además, la B y E son equivalentes, por lo que podemos asumir que no eran la respuesta esperada por quien redactó la pregunta.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 92 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un paciente de 76 años, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia, en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, aspirina, metformina y atorvastatina, fumador de 10 paquetes año, consulta por un cuadro de tos, expectoración y disnea, de 2 días de evolución, por lo que consulta al servicio de urgencia. Al examen físico presenta FR: 25x', PA: 150/100 mmHg, FC: 90x', saturación oxígeno: 86%. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar simétrico, con crepitaciones intensas bilaterales, mayores en las bases y algunas sibilancias. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): El diagnóstico más probable es:

A) Neumonía bilateral
B) Insuficiencia cardíaca descompensada
C) Bronquiectasias
D) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
E) Fibrosis pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la radiografía puede ser de fibrosis, el cuadro agudo, la edad y las comorbilidades hacen muy probable que se trate de una

---

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 153 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un adulto de 65 años, con antecedente de EPOC, consulta por aumento de su dis- nea basal asociado a expectoración mucopurulenta y fiebre hasta 38,3°C. Al examen fí- sico presenta frecuencia cardiaca de 95 por minuto, presión arterial 120/80mmHG, sa- tura 91%, frecuencia respiratoria de 27 por minuto. A la auscultación pulmonar presen- ta crépitos en base izquierda y se solicita radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO El tratamiento de elección es:

A) Cefuroximo oral
B) Penicilina endovenosa
C) Azitromicina oral
D) Amoxicilina oral
E) Ceftriaxona endovenosa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
A, C, E? Falta información sobre el estado general del paciente. Además no se sabe la saturación basal del paciente.Una saturación de 91%, por regla general requiere hos- pitalización y por tanto ceftriaxona (yo marque E), pero si basalmente desatura, por ser EPOC, podría bastar el tratamiento oral.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 139 1.05.1.027 · Neumonías adquiridas en la

Un paciente de 70 años, diagnosticado de EPOC, presenta un cuadro de mayor dificultad respiratoria, asociada a aumento de su expectoración, la que se vuelve mucopurulenta. Además presenta fiebre y disnea de reposo. Al examen físico se aprecia respiratoriamente apremiado, con PA: 120/80, FC: 95x'. Se solicita radiografía que se muestra a continuación: ¿Qué antibiótico debe recibir?

A) Claritromicina
B) Amoxicilina
C) Cefotaximo
D) Amoxicilina más ácido clavulánico
E) Clindamicina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Era un EPOC descompensado con una neumonía bilateral: se debe manejar hopitalizado, por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona (no aparecía en las alternativas, por lo que cefotaximo es la opción más adecuada: tiene el mismo espectro de acción). Sin embargo la Rx original no condensaba claramente y tenía un patrón alveolointersticial (discutible si sospechar mycoplasma, que se trata con macrólidos o levofloxacino, porque la clínica no era arrastrada ni atípica)

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 87 1.05.1.010 · Derrame pleural neoplásico

Un paciente de 56 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disnea progresiva de 2 meses de evolución, asociada a tos irritativa y compromiso del estado general. Sus signos vitales son FC: 88x', PA: 130/80 mmHg, saturación 93% a FiO2 ambiental y al examen pulmonar presenta matidez y crépitos en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, a derecha, el que se confirma con la TAC de tórax. Se realiza toracocentesis, que da salida a un líquido pleural opalescente, con LDH: 700 UI/L, mayor a 0,6 en relación a la LDH plasmática y proteínas mayores a 0,5, en relación a las proteínas plasmáticas, con 40 células por mm3, 90% de mononucleares, ADA: 24 UI/L y citología negativa. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Biopsia pulmonar por videotoracoscopía
B) Broncoscopía con biopsia pulmonar
C) PET-TC
D) Biopsia pleural por videotoracoscopía
E) Broncoscopía con lavado bronquioalveolar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un líquido pleural sugerente de cáncer (exudado: cumple todos los criterios de light; mononuclear; con ADA menor a 30). Dado que la radiografía no muestra un tumor pulmonar, se debe proceder a las biopsias pleurales, las que se hacen por videotoracoscopía y, si no está disponible, de manera percutánea.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 120 1.05.1.010 · Derrame pleural neoplásico

Paciente de 65 años de edad, fumador de 40 paquetes/año, consulta por disnea progresiva asociada a tos con expectoración escasa mucosa. Al examen físico se aprecia disminución de murmullo pulmonar en base pulmonar izquierda Se solicita radiografía de tórax que muestra derrame pleural en lado izquierdo, el cual se punciona mostrando LDH 250 mg/dL, 300 leucocitos (95% mononucleares) y ADA en 25. El diagnóstico más probable es:

A) Insuficiencia Cardiaca
B) Derrame pleural maligno
C) Tuberculosis
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Enfermedad del tejido conectivo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Derrame pleural maligno** (opción **B**). Exudado mononuclear con ADA baja. Es cáncer. Esta clase aborda la diferenciación entre amigdalitis bacteriana y viral, junto con la difteria y las anginas infecciosas. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 20 1.05.1.010 · Derrame pleural neoplásico

Un paciente de 60 años, fumador de 5 cigarrillos al día, consulta por disnea de esfuerzos que ha aumentado en el último tiempo. Ha bajado de peso cerca de 6 kilogramos en los últimos 3 meses. Como antecedente, trabajó durante 30 años en una fábrica de producción de pizarras de asbesto para la construcción. Al examen físico presenta signos vitales normales, edema de extremidades inferiores, yugulares visibles al decúbito y examen pulmonar con MP presente, disminuido a derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra derrame pleural marcado en el lado derecho, por lo que se realiza punción pleural, que da salida a líquido con 300 células por mm3, con 90% de mononucleares, ADA: 22 UI/L, proteínas: 6 g/dL, estudio citológico negativo, pH: 7,37, lactato: 3 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Carcinoma pavimentoso
B) Adenocarcinoma
C) Tuberculosis pleural
D) Mesotelioma
E) Silicosis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un derrame canceroso (exudado mononuclear con ADA baja) y el antecedente de exposición a asbesto está muy relacionado a mesotelioma.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 176 1.05.1.010 · Derrame pleural neoplásico

Un paciente de 45 años consulta por disnea de 2 meses de evolución que ha ido en aumento y se ha asociado a dolor torácico en el hemitórax izquierdo, además de tos seca. Como antecedente, refiere haber vivido gran parte de su infancia junto a una fábrica de fibrocemento. En su examen Fsico presenta frecuencia cardíaca 82 la8dos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg, frecuencia respiratoria 22 por minuto; el examen pulmonar muestra abolición del murmullo pulmonar del hemitórax izquierdo y ma8dez a la percusión en esa zona. Se solicita una radiograFa de tórax, que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Derrame pleural tuberculoso
B) Tromboembolismo pulmonar crónico
C) Carcinoma broncogénico
D) Silicosis pulmonar
E) Mesotelioma maligno

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La radiografía muestra un derrame pleural extenso a izquierda. El antecedente de exposición a asbesto (fibrocemento) orienta al mesotelioma como causa del derrame. Fuente imagen: Radiopaedia.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 116 1.05.1.010 · Derrame pleural neoplásico

Un paciente de 68 años presenta tos de 4 meses de evolución, y disnea de esfuerzos. Al examen pulmonar tiene disminución del murmullo pulmonar a derecha, más matidez en la base derecha. Punción pleural con líquido claro, pH: 7,47, células: 70 por mm3, 80% mononucleares, ADA: 20 UI/L, LDH: 167 UI/L, colesterol: 119 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Insuficiencia cardíaca
B) Tuberculosis pleural
C) Empiema
D) Cáncer bronquial
E) Derrame secundario a artritis reumatoide

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la LDH está menor a 180, el colesterol está mayor a 40, por lo que es un exudado (esa era la parte difícil). Además, es de predominio mononuclear, con ADA baja, por lo que probablemente es un cáncer. La A es un transudado. La B y E son exudados MN, pero tienen ADA alta (mayor a 50 o al menos mayor a 30). La C es un exudado PMN, con ADA alta también.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 139 1.05.1.038 · Nódulos pulmonares

Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente: La conducta más adecuada en este caso es:

A) Solicitar TAC de tórax
B) Realizar punción transpleural
C) Instalar tubo pleural con trampa de agua
D) Realizar toracocentesis diagnóstica
E) Realizar broncoscopía rígida

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho. Lo primero es el TAC. Luego será la Bx transbronquial, mediante broncoscopía. Si hubiese tenido radiografías previas, lo primero habría sido revisarlas, antes del TAC.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 63 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 40 años, hospitalizado hace 3 días por un síndrome nefrótico, presenta disnea, de inicio súbito. Presenta desaturación arterial hasta 90%, con disminución del murmullo pulmonar a derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido hemorrágico, con LDH: 700, predominio de polimorfonucleares, pH: 7,3 y lactato de 4,0 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Empiema
B) Derrame paraneumónico simple
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Transudado pleural
E) Compromiso pleural maligno

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El exudado hemorrágico orienta a TEP. También el Sd. nefrótico, que se complica con TEP. También el inicio súbito.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 21 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 55 años, está hospitalizado por una pancreatitis aguda, de diez días de evolución. Presenta un cuadro de fiebre, malestar general y taquipnea de 1 día de evolución. ¿Qué conducta es más adecuada?

A) Solicitar radiografía de tórax
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar ecografía abdominal
D) Solicitar angioTAC de tórax
E) Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar angioTAC de tórax** (opción **D**). La sospecha es un TEP.. Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 148 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 72 años es hospitalizado por fractura de cadera, manejada con cirugía de prótesis parcial. Al quinto día presenta pérdida de conciencia, luego de ponerse de pie, con recuperación completa algunos minutos después. Luego de ello presenta lipotimias y episodios similares al incorporarse desde la cama. Al examen físico está con FC: 120x', presión arterial: 100/50 mmHg, extremidades inferiores frías y con cianosis distal y ritmo cardíaco regular, sin soplos y murmullo pulmonar presente. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) TAC de cerebro
B) Ecocardiograma
C) RMN de cerebro
D) Electrocardiograma
E) AngioTAC de tórax

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene clínica sugerente de un TEP. Además, por estar taquicárdico y con tendencia a la hipotensión, sería un TEP masivo, que requiere de trombólisis, en lugar de simple anticoagulación. Sobre el diagnóstico del TEP masivo, se ha enseñado que el ecocardiograma es el examen de elección para enfrentarlo, pero eso solo ocurre cuando el paciente está muy descompensado, de manera que no está en condiciones de ir al angioTAC y, además, existe disponibilidad de realizar una ecocardiografía de urgencia "al pie de la cama". En este caso en que su presión sistólica es mayor a 90 mmHg, sí está en condiciones de ir a un angioTAC.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 140 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Puérpera de 15 días, inicia disnea y tos, asociada a expectoración, hemoptoica. Al examen pulmonar tiene murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos y satura 90% a FiO2 ambiental. El diagnóstico más probable es:

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumonía adquirida en la comunidad
C) Neumonía intrahospitalaria
D) Tuberculosis pulmonar
E) VIH

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Tromboembolismo pulmonar** (opción **A**). el antecedente de puerperio orienta muy fuertemente a TEP. La clínica es compatible.. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 97 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 68 años, con antecedente de cáncer de próstata, en tratamiento con hormonoterapia, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de dolor torácico, en el lado izquierdo, tipo puntada de costado, asociado a disnea, tos y fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Metástasis pulmonares
B) Neumotórax
C) Infarto agudo al miocardio
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Distrés respiratorio

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Tromboembolismo pulmonar** (opción **D**). Es un TEP clásico.. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 5 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 68 años presenta una fractura de cadera, de la que es operado. Al segundo día, presenta un síncope, que se recupera al a los pocos segundos. Su presión arterial es de 100/60 mmHg y su frecuencia cardíaca es 110. Además satura 91% a FiO2 ambiental. Su examen físico muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados y un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?

A) Ecocardiograma
B) Radiografía de tórax
C) AngioTAC de tórax
D) TILT test
E) Monitorización electrocardiográfica de 24 horas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (AngioTAC de tórax). La sospecha es un TEP.. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 121 · 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 56 años, diabético, hospitalizado en su quinto día, por un síndrome nefrótico, presenta un cuadro de disnea y dolor torácico, por lo que se realiza una radiografía de tórax, la que muestra un derrame pleural derecho. Se realiza la punción pleural, dado salida a un líquido pleural de aspecto hemorrágico, con LDH: 650 UI/L, células 80% de polimorfonucleares, 20% de mononucleares, ADA: 30 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Derrame paraneumónico
B) Trasudado por hipoalbuminemia
C) Empiema
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Derrame pleural canceroso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El antecedente de síndrome nefrótico orienta a TEP y la clínica también. Que tenga un líquido hemorrágico es clásico de TEP, que suele ser un exudado pleural hemorrágico, ya sea de predominio mononuclear o polimorfonuclear.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 167 · 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 75 años, con antecedentes de diabetes mellitus 8po 2, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstruc8va crónica e insuficiencia cardíaca conges8va en capacidad funcional II, presenta disnea más intensa de la habitual, desde hace 5 días, por lo que ha guardado reposo en cama recibiendo an8bió8cos y oxigenoterapia. El día de hoy presenta exacerbación súbita de su sintomatología con pérdida de conciencia, que se recupera algunos segundos después, y disnea de reposo. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 125 la8dos por minuto, presión arterial 160/100 mmHg, frecuencia respiratoria 30 por minuto y saturación de oxígeno 87%. El examen pulmonar muestra escasas sibilancias bilaterales y crépitos bibasales. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal sin alteraciones del segmento ST y la radiograFa de tórax muestra campos pulmonares grandes, sin opacidades. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Infarto agudo de miocardio
B) Disección aór2ca
C) Taponamiento cardíaco
D) Neumonía
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien inicialmente parecía una exacerbación del EPOC o la ICC, la descompensación súbita orienta fuertemente a un TEP, más todavía considerando que ha estado en reposo en cama, con ectasia. La taquicardia sinusal y la radiografía sin alteraciones disGntas a las esperadas para su patología de base son compaGbles (la radiografía suele ser normal en el TEP y la taquicardia sinusal es el hallazgo más frecuente, mucho más que el patrón S1Q3T3).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 134 · 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Una paciente consulta al servicio de urgencias por disnea y malestar de 2 horas de evolución. Refiere un viaje reciente en avión desde Europa hace 12 horas y es usuaria de anticonceptivos orales. Al examen físico, tiene presión arterial: 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca: 100x' y saturación arterial de oxígeno: 90%, su auscultación cardiopulmonar es normal, al igual que el resto de su examen físico. Se solicita un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto. ¿Cuál es el examen de elección para continuar con el estudio?

A) Dímero D
B) Ecocardiograma
C) AngioTAC de tórax
D) Péptido natriurético cerebral
E) Electrocardiograma Holter de 24 horas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Score de Wells para TEP: La paciente presenta dos criterios del score de Wells para TEP: taquicardia y cuadro clínico sugestivo de TEP sin otro diagnóstico más probable. Esto implica un riesgo intermedio que obliga a descartar la condición con imágenes. El angioTAC de tórax es la prueba de elección, ya que la paciente está hemodinámicamente estable. La otra forma de ver el caso es directamente ver que tiene un cuadro clínico compatible, con factores de riesgo y alteraciones en el examen físico, lo que da una probabilidad al menos intermedia de TEP, lo que obliga a solicitar un angioTAC en lugar de sólo un dímero D.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 86 · 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Mujer de 65 años operada de rodilla hace 48 horas presenta disnea súbita, taquicardia 115 lpm, saturación 89% y dolor pleurítico. Se sospecha tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?

A) Resonancia magnética
B) Angiografía pulmonar convencional
C) AngioTAC de tórax (protocolo TEP)
D) Radiografía de tórax
E) Ecografía Doppler de extremidades

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
AngioTAC de tórax (angiografía por TC) es el gold standard diagnóstico de TEP: sensibilidad y especificidad >90%. La angiografía convencional es invasiva y raramente usada. Ecografía Doppler solo si hay contraindicación para TAC. Radiografía es inespecífica.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 6 · 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 71 años, con antecedente de tabaquismo de 30 paquetes año, presenta tos de 2 meses de evolución de tos, asociado a baja de peso. Hace 2 días inició con disnea, asociada a dolor con tope inspiratorio. Hoy se agregó fiebre y expectoración hemoptoica. Al examen físico tiene FR: 20x', PA: 110/70 mmHg, FC: 96x', murmullo pulmonar presente, simétrico, con escasos crépitos bilaterales y ritmo regular en 2 tonos, sin ruidos agregados. ¿Cuál es el estudio más adecuado para el enfrentamiento de este paciente?

A) Radiografía de tórax
B) Ecocardiografía
C) Hemograma y hemocultivos
D) AngioTAC de tórax
E) Cultivos de expectoración

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (AngioTAC de tórax). La sospecha también es un TEP.. La enfermedad de Behçet es una vasculitis cuyas manifestaciones recuerdan a las pelvispondiloartropatías. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 98 · 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

Un paciente de 55 años, está hospitalizado por una pancreatitis aguda, de 10 días de evolución. Presenta un cuadro de fiebre, malestar general y taquipnea de 1 día de evolución. ¿Qué conducta es más adecuada?

A) Solicitar radiografía de tórax
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Realizar laparoscopía exploradora
D) Solicitar angioTAC de tórax
E) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar angioTAC de tórax** (opción **D**). Se sospecha un TEP y se estudia con angioTAC de tórax.. Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 147 · 1.05.1.015 · Embolia pulmonar

expectoración mucosa, que en ocasiones es hemoptoica, asociado a disnea de esfuerzos. Además, ha bajado de peso 4 kilogramos y presenta dolor torácico, con tope inspiratorio. Al examen físico FC: 110 x', PA: 100/60 mmHg, ritmo regular en dos tiempos, con ruidos cardíacos apagados, asimetría del murmullo pulmonar y crépitos escasos bilaterales, mayores a izquierda. En sus exámenes de laboratorio destaca hematocrito: 30%, hemoglobina: 9,9 g/dl, blancos: 10.000 por mm3, dímero D: 649 ng/ml (valor normal: menor a 100), LDH: 760 Ul/L. Se realiza radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: researchgate.net): ¿Cuál la conducta diagnóstica más adecuada a seguir?

A) Broncoscopía
B) TAC de tórax
C) Videotoracoscopía
D) Baciloscopías de expectoración
E) AngioTAC de tórax

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy difícil, pero su clínica sugiere un cáncer pulmonar. Su radiografía muestra un derrame izquierdo. Además, actualmente, dado el dolor con tope inspiratorio (que no indican hace cuánto tiempo tiene), la taquicardia, la elevación del dímero D y la LDH, se debe descartar en primer lugar un TEP, en especial, porque tiene el cáncer como factor de riesgo. Por ello, la respuesta es angioTAC de tórax.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 175 · 1.05.1.017 · Enfermedad pulmonar obstru

Espirometría con VEF1/CVF 0.35, no mejora post broncodilatador, VEF1 50%

A) Fibrosis pulmonar
B) Insuficiencia cardiaca derecha
C) EPOC
D) Asma
E) Bronquiectasias

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (EPOC). Patrón obstructivo severo no reversible = EPOC. Esta clase aborda las intoxicaciones alimentarias, las diarreas con sus microorganismos y el cólera. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 14 · 1.05.1.017 · Enfermedad pulmonar obstru

Un paciente de 65 años, fumador de 40 paquetes año, consulta por disnea de algunos meses de evolución, progresiva, que actualmente le dificulta caminar más de 3 cuadras. Su examen físico demuestra espiración prolongada y algunas sibilancias en ambos campos pulmonares. Actualmente ya no fuma. Se solicita espirometría que muestra lo siguiente: Basal Litros % Post SBT Litros % CVF 2,68 90 CVF 2,96 102 VEF1 1,35 50 VEF1 1,38 51 VEF1/CVF 55 VEF1/CVF 57 FEF25-75 FEF25-75 ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Salbutamol inhalado
B) Budesonida inhalada
C) Ipatropio inhalado
D) Fluticasona inhalada
E) Tiotropio inhalado

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene el diagnóstico de EPOC (con espirometría obstructiva, que no mejora con BD). Lo más correcto es que inicie BD de larga acción, más BD de corta acción por horario, pero esto no aparecía en las opciones. Sin embargo, la base del tratamiento del EPOC estable es suspender el cigarrillo y los broncodilatadores de larga acción, como tratamiento sintomático.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 135 · 1.05.1.017 · Enfermedad pulmonar obstru

Un paciente de 55 años, fumados de 30 paquetes-año, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva. Su examen físico no muestra alteraciones. Se solicita una radiografía de tórax, que no muestra alteraciones y se realiza una espirometría, que muestra un VEF1 de 60%, que no mejora con broncodilatodor. El diagnóstico más proable es:

A) Bronquitis crónica
B) Hipertensión pulmonar
C) EPOC
D) Asma
E) Fibrosis pulmonar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien el Dg. de EPOC se hace con la relación VEF1/CVF (menor a 70%), el VEF1 bajo orienta mucho. Que no mejore con broncodilatador descarta asma y orienta a EPOC. La pregunta en sí está mala, pero probablemente será EPOC la respuesta correcta.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 71 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Un paciente de 66 años, hipertenso, fumador de 40 paquetes-año consulta por un cuadro de tos, de 2 meses de evolución, con expectoración mucosa o mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica asociados a baja de peso. Al examen físico, tiene disminución del murmullo pulmonar bilateral, mayor a derecha, con crepitaciones pulmonar en el lado derecho. Se palpan adenopatías supraclaviculares bilaterales y se constata hipocratismo digital. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 29%, hemoglobina: 9,5 g/dl, leucocitos: 11.000 por mm3, plaquetas: 140.000 por mm3. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.medicinainternaaldia.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumonía multifocal
B) Quiste hidatídico
C) Atelectasia
D) Derrame pleural
E) Cáncer pulmonar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cáncer de Pulmón: El cuadro clínico y la radiografía sugerían un cáncer de pulmón, pero ninguna de las opciones del Eunacom real tenían dicha respuesta. Así es el Eunacom y no se puede reclamar. Para efectos de subirlo a la plataforma, incluimos la opción.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 90 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Paciente fumador con baja de peso, hemoptisis ocasional y dolor costal. Radiografía con masa pulmonar. ¿Diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis pulmonar cavitada
B) Cáncer pulmonar
C) Absceso pulmonar
D) Sarcoidosis pulmonar
E) Linfoma pulmonar primario

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Cáncer pulmonar** (opción **B**). Cáncer pulmonar. Esta clase diferencia la fiebre sin foco (FSF) de la fiebre de origen desconocido (FOD). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 144 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Una paciente de 63 años, con antecedente de diabetes e hipertensión mal controladas, fumadora de 40 paquetes años y alcohólica activa, consulta por dolor torácico izquierdo, que aumenta con los movimientos respiratorios, asociado a tos con expectoración mucosa, que, en ocasiones es hemoptoica. Ha bajado de peso y refiere disnea de esfuerzos desde hace algunos meses. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 65x', PA: 150/98 mmHg, saturación de oxígeno por pulsometría: 95% a FiO2 ambiental, examen pulmonar con murmullo vesicular simétrico, con escasos crépitos a izquierda y, además, refiere dolor a la palpación de quinto arco costal izquierdo. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Absceso pulmonar
B) Neumonía neumocócica
C) Tuberculosis pulmonar
D) Disección aórtica
E) Cáncer pulmonar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Cáncer pulmonar** (opción **E**). Esta clase diferencia la fiebre sin foco (FSF) de la fiebre de origen desconocido (FOD). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 11 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Un paciente de 76 años, jubilado de la minería y fumador de 20 paquetes año consulta por tos y disnea de 2 meses de evolución, asociada a expectoración mucosa, que a veces tiene estrías de sangre. Ha bajado 4 kilogramos de peso y presenta astenia. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar conservado, bilateral, con escasos crépitos y sibilancias, mayores en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Foto 3 (https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082004000400006) ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

A) TAC de tórax
B) Broncoscopía
C) Baciloscopías
D) PET
E) Resonancia magnética de tórax

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta discutible. Lo primero a revisar siempre son las radiografías previas. Luego, el TAC es el examen de elección para el enfrentamieinto del nódulo pulmonar. Sin embargo, el PET/TC ha demostrado ser de gran utilidad (a pesar de falsos positivos), por lo que también es una respuesta potencialmente correcta. Luego se hace la biopsia por broncoscopía.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 136 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Un paciente de 60 años, hipertenso, fumador de 25 paquetes-año, consulta por tos de algunos meses de evolución. Su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se realiza radiografía que se muestra a continuación. NOTA: la foto original no mostraba nada categórico. Era similar a la que se muestra, pero no tenía flecha.

A) Cáncer
B) Tuberculosis pulmonar
C) Fibrosis pulmonar
D) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
E) Cardiopatía hipertensiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La radiografía no mostraba mucho (en la Rx original no había flecha y se veía, usando la imaginación, un engrosamiento bronquial o mediastínico derecho). Casi se veía normal. Pero tos en alguien muy fumador, con examen físico normal, pensar en Cáncer (no tenía secreción como para pensar en bronquitis crónica por cigarrillo).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 9 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Un paciente de 55 años, fumador de 20 paquetes años, consulta por tos de 3 meses de evolución, asociado a disnea y expectoración mucosa. Al examen físico se ausculta murmullo pulmonar conservado, sin ruidos agregados. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Asma bronquial
B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C) Cáncer bronquial
D) Hidatidosis pulmonar
E) Enfermedad pulmonar intersticial

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un cáncer bronquial o pulmonar clásico, tanto por la clínica, como por la imagen. Revisar el resumen de semiología respiratoria.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 7 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Un paciente de 60 años, fumador de 40 paquetes años, consulta por disnea de 3 meses de evolución, asociado a tos con expectoración mucosa. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x' y a la auscultación pulmonar se constatan escasos crépitos y algunas sibilancias, que son mayores en el campo pulmonar izquierdo. Se realiza una radiografía, que se muestra a continuación: Fuente: radiopaedia.org ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Biopsia pulmonar por fibrobroncoscopía
B) TAC de tórax
C) Fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar
D) Biopsias por videotoracoscopía
E) Resonancia magnética nuclear de tórax

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un tumor pulmonar izquierdo y la clínica sugiere cáncer. Luego de la RxTx se recomienda una TAC, antes de proceder a la biopsia (por broncoscopía, en este caso), ya que que permite ver la ubicación, características y estado de diseminación, además de ayudar a detectar otros diagnósticos diferenciales.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 29 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Imagen radiográfica de tórax PA en hombre de 62 años, fumador, que muestra masa hiliar derecha irregular con atelectasia del lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Carcinoma espinocelular (epidermoide) de pulmón
B) Derrame pleural
C) Neumotórax espontáneo
D) Neumonía por aspiración
E) Adenocarcinoma periférico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Masa hiliar central en fumador con atelectasia lobar = carcinoma espinocelular (epidermoide), el más frecuente en fumadores y de localización central. Produce obstrucción bronquial y atelectasia distal.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 65 1.05.1.007 · Cáncer bronquial primario

Un paciente de 60 años, fumador de 40 paquetes años, consulta por disnea de 3 meses de evolución, asociado a tos con expectoración mucosa, que en ocasiones es hemoptoica y que se ha asociado a baja de peso no cuantificada. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x', saturación O2: 95%. A la auscultación pulmonar se constatan escasos crépitos y algunas sibilancias, que son mayores en el campo pulmonar izquierdo. Se realiza una radiografía, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Biopsia pulmonar por fibrobroncoscopía
B) TAC de tórax con contraste
C) Fibrobroncoscopía con lavado bronquioalveolar
D) Biopsias por videotoracoscopía
E) Resonancia magnética nuclear de tórax

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una masa pulmonar (mayor a 3 cm, por lo que se presume maligna), más una clínica sugerente de cáncer. Se prosigue el estudio con una TAC, ya que delimita mejor el tumor y su ubicación, evalúa las adenopatías y descarta otras causas. Luego se biopsia idealmente por broncoscopía, si es accesible por vía bronquial.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 137 1.05.1.026 · Neumoconiosis

Un paciente de 67 años, fumador de 15 paquetes-año, pero que dejó de fumar hace 10 años, jubilado de la minería, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, de 6 meses de evolución, asociada a tos. Al examen físico presenta murmullo pulmonar globalmente disminuido, sibilancias y roncus bilaterales, asociados a crepitaciones difusas. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: NOTA: la radiografía inicial mostraba infiltrados bilaterales, mayores en las zonas centrales, con imágenes verticales, onduladas de 1-2 cm en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Bronquitis crónica
B) Neumoconiosis
C) Cáncer de pulmón
D) Limitación crónica del flujo aéreo
E) Fibrosis pulmonar idiopática

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Neumoconiosis** (opción **B**). Antecedente de minería orienta a neumoconiosis. La Rx era distinta a la que ahí se muestra.. Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 89 1.05.1.026 · Neumoconiosis

Trabajador de la minería, fumador leve, con disnea, sibilancias, hiperinsuflación y espirometría obstructiva no reversible. ¿Diagnóstico más probable?

A) EPOC por tabaquismo
B) Asma ocupacional
C) Fibrosis pulmonar idiopática
D) Silicosis pulmonar
E) Neumoconiosis por carbón (antracosis)

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Silicosis pulmonar** (opción **D**). Silicosis pulmonar. Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 109 · 1.05.1.026 · Neumoconiosis

Un paciente de 48 años, que trabaja como operador de maquinaria de la minería, consulta por disnea de esfuerzo de 2 años de evolución, que ha progresado en el último tiempo, asociado a tos con expectoración mucosa ocasional. Al examen físico tiene PA: 108/72 mmHg, FC: 70x', aumento del diámetro anteroposterior del tórax, espiración prolongada y, a la auscultación pulmonar, se oyen sibilancias bilaterales. Se realiza espirometría que muestra lo siguiente: VEF1 CVF VEF1/CVF Basal 2.532 cc (59%) 4.870 cc (99%) 52% Postbroncodilatador 2.659 cc (62%) 5.017 cc (102%) 53% ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
B) Asma bronquial
C) Hipertensión pulmonar
D) Insuficiencia cardíaca
E) Fibrosis pulmonar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fibrosis pulmonar** (opción **E**). Las enfermedades intersticiales pulmonares difusas tienen múltiples causas, siendo la fibrosis pulmonar idiopática (FPI/UIP) la más frecuente y de peor pronóstico, sin tratamiento específico más allá del sintomático (oxígeno, salbutamol). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 138 · 1.05.1.012 · Derrame pleural paraneumón

Un paciente de 50 años presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está se auscultan crepitaciones basales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra más abajo: NOTA: la radiografía mostraba infiltrados en la base izquierda, que ocupaban el lóbulo inferior izquierdo, pero que permitían ver la cúpula diafragmática, con un pequeño derrame pleural, limitado al ángulo costofrénico. Se punciona el derrame pleural, que muestra un lactato: 2,4 mmol/L, pH: 7,34, con 350 células, 90% de polimorfonucleares. ¿Qué antibiótico debe dejar?

A) Claritromicina
B) Clindamicina
C) Ceftriaxona
D) Azitromicina
E) Amoxicilina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por ser una neumonía, con derrame (paraneumónico simple en este caso), se debe manejar hospitalizada (ATS III), por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 142 · 1.05.3.004 · Tabaquismo: prevención, ce

Un paciente fuma 5 a 7 cigarrillos al día y consulta porque quiere dejar de fumar. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

A) Terapia cognitivo conductual
B) Terapia de sustitución con nicotina
C) Sertralina
D) Bupropión
E) Cigarrillo electrónico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fuma muy poco, como para que requiera burpopión o nicotina. Además la terapia cognitivo conductual siempre es la más efectiva para dejar de fumar.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 81 · 1.05.1.033 · Síndrome de apnea del sueñ

Un Paciente de 52 años con historia de ronquidos frecuentes, de larga data, que desde hace 5 años, se asocia a somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Al examen físico tiene frecuencia cardiaca de 75x' y presión arterial de 140/100 mmHg. Su IMC es de 35. Se realiza polisomnografía que evidencia índice de apenas de 50 eventos de apnea / hipopnea por hora, con predominio de los eventos obstructivos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Oxígeno nocturno
B) C-PAP nocturno
C) Cirugía bariátrica
D) Uvulopalatoplastía
E) Dispositivo orofaríngeo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño severa (>30 eventos por hora; moderada es entre 20 y 30; leve es <20), por lo que requiere C- PAP (se indica en la severa y en la que no responde al tratamiento médico de baja de peso y cambios de posición al dormir). La cirugía podría servir, pero requiere de obstrucción anatómica y además, dada la severidad, el C-PAP igual es de elección.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 13 · 1.05.1.033 · Síndrome de apnea del sueñ

Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diur- na. Refiere que ronca en la noche y se queda dormido en las luces rojas del semáforo. En su examen físico destaca PA: 140/90 mmHg, FC: 72x' y faringe normal. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

A) Poligrafía nocturna
B) Polisomnografía
C) Saturación arterial de oxígeno durante el sueño
D) Monitorización de presión arterial de 24 horas
E) Nasofibroscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Polisomnografía). Es un SAHOS, que se estudia con polisomnografía.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 86 · 1.05.1.033 · Síndrome de apnea del sueñ

Un paciente de 78 años, con sobrepeso, presenta alteraciones de la memoria y dificultades para concentrarse, que iniciaron hace 2 años y que han progresado, asociado a hipersomnia y cansancio. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Electrocardiograma
B) Ecocardiograma
C) Polisomnografía
D) RMN de cerebro
E) TAC de cerebro

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una apnea obstructiva del sueño, por el sobrepeso e hipersomnia. Las alteraciones de la memoria son causadas por la privación de sueño adecuado.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 75 1.05.1.033 · Síndrome de apnea del sueñ

Un paciente de 78 años, IMC: 32, presenta alteraciones de la memoria, desde hace 2 años, que han progresado, asociado a desconcentración e hipersomnia. ¿Cuál es el diagnóstico de elección para iniciar el estudio?

A) Electrocardiograma
B) Ecocardiograma
C) Polisomnografía
D) RMN de cerebro
E) TAC de cerebro

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Que tenga hipersomnia hace sospechar que haya un SAHOS, por lo que se debe estudiar con una polisomnografía.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 146 1.05.1.033 · Síndrome de apnea del sueñ

Paciente con apnea del sueño, tenía polisomnografía con 65 episodios por hora, hipertrofia de cornetes conducta:

A) CPAP
B) Cirugía de cornetes
C) Laparotomía exploratoria
D) Cirugía laparoscópica
E) Manejo conservador

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **CPAP** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Cirugía de cornetes, Laparotomía exploratoria) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 98 1.05.1.009 · Daño pulmonar secundario a

Mujer de 56 años cardiópata y con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con espironolactona, isosorbide, hidralazina, amiodarona y anticoagulante oral. Inicia hace 6 meses un cuadro de disnea y tos seca. A la exploración pulmonar tiene crépitos bibasales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Suspender amiodarona
B) Solicitar TAC de tórax
C) Aumentar diurético
D) Solicitar ecocardiograma
E) Solicitar fibrobroncoscopia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien es imposible ver bien la radiografía, la historia sugería mucho una fibrosis pulmonar por amiodarona, por lo que se debe suspender.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 93 1.05.1.009 · Daño pulmonar secundario a

Paciente usuario de amiodarona con disnea progresiva y tos; radiografía con infiltrados bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender amiodarona
B) Iniciar corticoides sistémicos
C) Agregar antibiótico de amplio espectro
D) Solicitar broncoscopía diagnóstica
E) Aumentar dosis de amiodarona y agregar corticoide

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suspender amiodarona** (opción **A**). Suspender amiodarona. Tratamiento: penicilina endovenosa; en forma respiratoria ciprofloxacino + clindamicina. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 106 1.05.1.009 · Daño pulmonar secundario a

Una paciente de 68 años, con antecedente de hipertensión y cardiopatía hipertensiva, en tratamiento con losartán y clortalidona, que, además, tiene fibrilación auricular crónica, en tratamiento con amiodarona y rivaroxabán, consulta por un cuadro de disnea progresiva que se ha instalado en los últimos meses, que actualmente es de medianos esfuerzos y se asocia a tos seca, mayor en la noche. Al examen físico tiene pulso regular a 74x', PA: 130/80 mmHg, examen pulmonar con crepitaciones bilaterales, examen cardiaco: RR2T sin soplos, con abdomen y extremidades sin alteraciones. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar salbutamol
B) Agregar espironolactona
C) Suspender el rivaroxabán
D) Suspender la amiodarona
E) Agregar furosemida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suspender la amiodarona** (opción **D**). Tratamiento: penicilina endovenosa; en forma respiratoria ciprofloxacino + clindamicina. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 9 1.05.1.004 · Bronquiectasias

Un paciente de 40 años, con antecedente de neumonías a repe8ción y consumo de tabaco de 5 paquetes-año, consulta por tos frecuente y produc8va, mayor durante las mañanas, con expectoración mucosa y, en ocasiones, hemoptoica. Al examen Fsico presenta dedos en palillo de tambor (acropaquias), frecuencia cardíaca 75 lpm y presión arterial 110/70 mmHg. La auscultación cardiopulmonar revela ritmo regular en dos tonos sin soplos, murmullo pulmonar presente y simétrico, con auscultación de crepitaciones y estertores bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Bronqui2s crónica
B) Bronquiectasias
C) Carcinoma broncogénico
D) Tuberculosis pulmonar
E) Insuficiencia cardíaca conges2va

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un cuadro compaGble con bronquiectasias. Se debe revisar el resumen de semiología respiratoria. El diagnóstico se confirma con TAC de tórax de alta resolución.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 119 1.05.1.004 · Bronquiectasias

Un paciente de 26 años de edad presenta un cuadro de tos con expectoración de algunos años de evolución, mayor en las mañana y que ha presentado hemoptisis. Su examen físico presenta acropaquias y a la auscultación pulmonar hay crepitaciones y estertores bilaterales. El diagnóstico más probable es:

A) Bronquiectasias
B) Cáncer pulmonar
C) Tuberculosis pulmonar
D) Asma
E) EPOC

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Son bronquiectasias clásicas (persona joven con clínica respiratoria, hemoptisis, broncorrea, infecciones recurrentes y estertores y sibilancias). Las acropaquias se ven en A, B y C, pero son más frecuentes en el cáncer de pulmón.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 87 1.05.1.004 · Bronquiectasias

Paciente con infecciones respiratorias recurrentes y expectoración matinal de 200 mL al día. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio?

A) Broncoscopía con lavado broncoalveolar
B) Espirometría con test de reversibilidad
C) TAC de tórax de alta resolución
D) Radiografía de tórax seriada
E) Cultivo de esputo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (TAC de tórax de alta resolución). TAC de tórax de alta resolución. El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 107 1.05.1.004 · Bronquiectasias

Una paciente de 45 años, con antecedente de infecciones respiratorias a repetición en la infancia, presenta broncorrea de cerca de 300cc al día, mayor en la mañana, asociada a disnea de esfuerzos y tos con expectoración. Además, refiere cuadros de exacerbación de sus síntomas que ocurren varias veces al año, por lo que usa antibióticos. Al examen físico tiene signos vitales dentro de rango normal y, en la auscultación pulmonar se objetiva espiración prolongada, además de auscultarse estertores y sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.sciencephoto.com): ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el diagnóstico?

A) Recuento de inmunoglobulina A, G y M
B) TAC de tórax
C) Baciloscopías y cultivo para micobacterias
D) Lavado bronquioalveolar
E) Broncoscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **TAC de tórax** (opción **B**). El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 143 1.05.1.004 · Bronquiectasias

Un paciente de 32 años, presenta infecciones respiratorias recurrentes, desde su infancia, que en varias ocasiones han requerido de antibióticos, asociado a disnea de esfuerzos. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,5°C y al examen pulmonar se auscultan múltiples crépitos y sibilancias bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: Fuente: http://www.lungindia.com/ El examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico es:

A) Fibrobroncoscopía
B) Cuantificación de inmunoglobulinas
C) TAC de tórax
D) Test del sudor
E) Espirometría

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene imágenes sugerentes de bronquiectasias bilaterales. El resto del cuadro clínico es compatible con una FQ, a pesar de la edad (neumonías bacterianas a repetición: habitualmente por S. aureus y P. aureginosa).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 18 1.05.1.004 · Bronquiectasias

Una paciente de 23 años, que desde la infancia tiene tos frecuente, con expectoración abundante, mayor en la mañana, que en ocasiones es hemoptoica. Además una o dos veces al año, se exacerba los síntomas, con necesidad de uso de antibióticos. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: FOTO (radiografía de tórax AP con afectación en ambas bases, en patrón broncointersticial). ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Recuento de inmunoglobulinas
B) Test del sudor
C) Resonancia magnética de tórax
D) TAC de tórax
E) Baciloscopías de expectoración

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (TAC de tórax). La clínica es de bronquiectasias, que se diagnostican preferentemente con un TAC de tórax.. El síndrome de Sjögren se manifiesta principalmente con un síndrome de sicca (sequedad), que es su manifestación más frecuente y a veces la única. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 57 1.05.1.004 · Bronquiectasias

Un paciente de 22 años, que desde la infancia tiene infecciones respiratorias a repetición, que requerían uso de antibiótico. Al examen físico, es mesomorfo, con FC: 72x', PA:120/80 mmHg, su examen físico presenta crepitaciones y estertores bilateral. Se solicita radiografía de tórax que muestra múltiples imágenes de dilataciones bronquiales bilaterales, compatibles con bronquiectasias. ¿Cuál es el examen para proseguir el estudio?

A) Broncoscopía con biopsia bronquial
B) Prueba de provocación bronquial con metacolina
C) Espirometría
D) Test del sudor
E) Baciloscopías de expectoración

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una sospecha de FQ en el adulto, tanto por las infecciones bacterianas, como por las bronquiectasias (en otro año, más difícil aún, se puso una RxTx con imágenes que sugerían bronquiectasias). Se estudia con test del sudor. Es una patología AUGE, así que se pregunta bastante. La A serviría para la enfermedad de cilio inmóvil, que suele tener la misma clínica, más situs inversus en la mitad de los casos.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 126 1.05.4.013 · Pruebas cutáneas de alergi

Un hombre de 30 años, con rinorrea frecuente, se realiza prueba cutánea (prick test), que muestra reacción de 5mm a pólenes y de 0 mm al control histamina. ¿Cuál es la interpretación más adecuada de esta prueba?

A) Es alérgico
B) Está sensibilizado a pólenes
C) Tiene rinitis vasomotora
D) Tiene sinusitis crónica
E) Anergia cutánea

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

En mi opinión, es una pregunta con error, ya que el control positivo (con histamina) resulta 0 mm, lo que habitualmente significa que está usando antihistamínicos y el examen no sirve, por la anergia cutánea farmacológica, sin embargo, también resulta negativo para todo lo demás. En cambio, en este caso, resultó positivo para pólenes (>3 mm), lo que es imposible según lo anterior, pero da cuenta que está sensibilizado para pólenes. Por eso, dejaremos como respuesta correcta la B. Lo más correcto es que hubiese dicho que el control con suero fisiológico estaba en 0 mm y no el de la histamina. No es posible afirmar que sea alérgico, ya que ese es un diagnóstico clínico y no mediante el prick test.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 155 1.05.1.006 · Bronquitis crónica

Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer de pulmón
B) Tuberculosis pulmonar
C) Fibrosis pulmonar
D) EPOC
E) Bronquitis crónica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una bronquitis crónica clásica: fumador con tos y expectoración crónicas, mayores en la mañana. No tiene EPOC, porque su espirometría está normal. Asimismo, la radiografía normal hace improbables las demás opciones. Finalmente, la clínica no es sugerente de ninguna de las otras.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 27 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.928cc 100% 6.106cc 103% VEF1 4.163cc 76% 5.040cc 92% VEF1/CVF 65% 73% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Asma bronquial
B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C) Bronquiectasias
D) Bronquitis crónica
E) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Asma bronquial** (opción **A**). Tiene un cuadro clínico y espirometría (patrón obstructivo que mejora con BD) compatibles con asma.. La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es una mezcla de manifestaciones de artritis reumatoide (artritis), lupus (úlceras orales, rash malar, pericarditis, lupus cutáneo subagudo), esclerodermia (fenómeno de Raynaud, disfagia, esclerodactilia) y miositis (como en la polimiositis/dermatomiositis), pudiendo además complicarse con síndrome de Sjögren. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 17 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Una paciente de 43 años, ex fumadora de 8 paquetes año, consulta por disnea, aso- ciada a tos con expectoración mucosa y respiración sibilante, que aparecen después de realizar ejercicio o presentar infecciones virales. Al examen físico presenta disminu- ción del murmullo pulmonar, sibilancias espiratorias y aumento del diámetro antero- posterior toráxico. Se realiza una radiografía que se muestra a continuación: INSERTAR FOTO El tratamiento inicial más adecuado es:

A) Salmeterol inhalado
B) Ipratropio inhalado
C) Budesonida inhalado
D) Salbutamol inhalado
E) Tiotropio inhalado

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un asma y lo más correcto es iniciar salbutamol SOS, más un corticoide inhala- do (budesonida en este caso). Por tanto es una mala pregunta. Si fuerzan a elegir el tra- tamiento “inicial”, yo creo que la respuesta es salbutamol.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 68 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

años de evolución. En ocasiones, los síntomas aumentan significativamente, especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador POE | 5.928cc 100% 6.106cc 103% MEF] ao0o 504000 VEFYCVE jes | [78% | Su radiografía de tórax se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): El diagnóstico más probable es:

A) Asma bronquial
B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C) Bronquiectasias
D) Bronquitis crónica
E) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un asma, por tener un patrón obstructivo (VEF1/CVF menor a 70%), que mejora con broncodilatador (sube más de 15% en cualquiera de los parámetros. Nota: no son 15 puntos porcentuales, sino 15%. Ejemplo, 76% a 92% hay 16 puntos porcentuales, pero subió 21%, ya que 16/76 = 0,21). La radiografía es normal. 10 paquetes-año ya aumenta el riesgo de EPOC y cáncer, pero lo habitual es que estas enfermedades aparezcan sobre 15 paq-año.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 19 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Una paciente con antecedente de rinitis alérgica y asma consulta por disnea frecuente, asociada a respiración sibilante y tos, que aparece con frecuencia luego de exponerse a los alergenos, en la noche, cuando cursa con alguna infección respiratoria alta o después de realizar ejercicio. Al examen físico tiene FR: 13 rpm, satura 96% a FiO2 ambiental y en su examen pulmonar destacan sibilancias espiratorias bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada con ella?

A) Evitar los alergenos por 3 meses
B) Iniciar salmeterol 2 puff cada 12 horas
C) Iniciar salbutamol 2 puff cada 6 horas
D) Iniciar fluticasona 2 puff cada 12 horas
E) Iniciar terapia de desensibilización a los alergenos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo más correcto es indicar corticoides inhalados cada 12 horas, más salbutamol SOS, pero de las opciones, la D era la más aceptable.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 63 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Un paciente de 62 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.810cc 98% 5.870cc 99% VEF1 3.835cc 70% 4.696cc 91% VEF1/CVF 66% 80% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Asma bronquial
B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C) Bronquiectasias
D) Bronquitis crónica
E) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque por la edad y por el tabaquismo podría ser un EPOC, la verdad es que lo habitual es que el EPOC tenga más de 15 paquetes-año y, lo más importante, en este caso la espirometría es un patrón obstructivo que mejora con BD, por lo que está confirmado el diagnóstico de asma.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 76 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Paciente de 45 años, fumadora activa de 40 paquetes año, consulta por tos irritativa asociada a disnea y crisis de sibilancias que aparecen en relación a la actividad física e infecciones respiratorias. Se realiza una espirometría que muestra: Basal: VEF1/CVF: 62% VEF1: 2,4L (62% del valor teórico) CVF: 4,9L (92% del valor teórico) Post-Salbutamol VEF1/CVF: 74% VEF1: 3,6L (89% del valor teórico) CVF: 5,0L (95% del valor teórico)

A) Asma
B) EPOC
C) Fibrosis pulmonar
D) Bronquiectasias
E) Bronquitis crónica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Asma). Es un patrón obstructivo, que mejora con broncodilatador, es decir, un asma.. La enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC) es una mezcla de manifestaciones de artritis reumatoide (artritis), lupus (úlceras orales, rash malar, pericarditis, lupus cutáneo subagudo), esclerodermia (fenómeno de Raynaud, disfagia, esclerodactilia) y miositis (como en la polimiositis/dermatomiositis), pudiendo además complicarse con síndrome de Sjögren. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 146 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Una paciente de 24 años presenta tos frecuente y disnea, asociada a sibilancias, que son mayores en la noche y que aumentan con el ejercicio, cuando fuma y en la primavera. Al examen físico presenta espiración prolongada y examen pulmonar con sibilancias bilaterales inspiratorias y espiratorias. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Evitar la exposición a desencadenantes
B) Salbutamol inhalado cada 6 horas
C) Budesonida inhalada cada 12 horas
D) Salmeterol inhalado cada 12 horas
E) Desensibilizar para los alérgenos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
[Pregunta disputada] Es una pregunta técnicamente mala, ya que debe recibir corticoides inhalados (C) más broncodilatadores de corta acción (B) y, dada la abundancia de síntomas, probablemente también de larga acción (D). Además, obviamente debe dejar de fumar (A). De las opciones, tengo la impresión de que la respuesta podría ser C, porque los corticoides son los que previenen la aparición de síntomas, aunque el salbutamol debe indicarse de inmediato, por estar tan sintomático, aunque no cada 6 horas, sino SOS.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 16 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Paciente de 22 años con episodios de disnea y sibilancias. Radiografía de tórax PA y lateral: hiperinsuflación bilateral, horizontalización de costillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Asma bronquial
B) Neumotórax espontáneo
C) Derrame pleural bilateral
D) Neumonía bilateral
E) Fibrosis quística

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hiperinsuflación en radiografía de tórax durante crisis de disnea con sibilancias en joven = asma bronquial. El atrapamiento aéreo produce la imagen de hiperinsuflación.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 127 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Un paciente de 38 años, con antecedente de asma bronquial en tratamiento con flu8casona inhalada, 1 puff de 250 mcg cada 12 horas, y salbutamol, 1 puff en caso de necesidad, y rini8s alérgica en tratamiento con loratadina 10 mg al día, presenta aumento de su sintomatología en primavera, requiriendo uso frecuente de salbutamol 2 a 3 veces al día. Al examen Fsico está en buenas condiciones, eupneico y en su examen pulmonar se auscultan sibilancias bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de flu2casona inhalada
B) Indicar salbutamol en horario
C) Prohibir la ac2vidad :sica al aire libre
D) Agregar inhibidor del receptor de leucotrienos
E) Mantener tratamiento

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discuGble, más aún si tomamos en cuenta que disGntas guías sobre el tratamiento de asma dicen cosas diferentes. A conGnuación, el resumen de lo recomendado por la guía GINA: El régimen de elección (Track 1) uGliza MART ("Terapia de Mantención And Rescate"), a base de formoterol + corticoides (budesonida) - Paso 1: MART SOS. - Paso 2: Agregar MART 1 puff al día horario (aceptable mantenerlo solo SOS). - Paso 3: Agregar MART horario. - Paso 4: Subir dosis de cor<coides del MART. - Paso 5: Agregar LAMA (antimuscarínicos de larga acción, ej. Gotropio) horario y evaluar biológicos (ej. anticuerpos anti-IgE, anti-IL-5, anti-IL-5R, anti-IL-4R). El régimen alterna<vo (Track 2) es el clásico y más usado en Chile uGliza salbutamol SOS como rescate más una terapia de mantención según horario. - Paso 1: Salbutamol SOS + cor<coides SOS (disGntos puff o mezcla). Ya no se recomienda el uso de salbutamol en monoterapia para el manejo crónico. - Paso 2: Agregar cor<coides inhalados 1 vez al día. - Paso 3: Agregar betaagonistas de larga acción (LABA), ej. salmeterol o formoterol). - Paso 4: Subir dosis de cor<coide inhalado. - Paso 5: Mantención con 3 fármacos: corticoides + LABA + LAMA y evaluar biológicos. Ahora volviendo a la pregunta, no estaba dentro de las opciones agregar un broncodilatador de larga acción (ej. formoterol), que hubiese sido la respuesta más correcta. Las dos opciones aceptables serían aumentar la dosis del corticoides y agregar inhibidores de leucotrienos. Por un lado, ya está con una dosis moderada de corticoides (saber esa dosis no es algo que deba hacer el médico general), por lo que no parece correcta subirla. Por otro lado, aunque los inhibidores de leucotrienos Genen algún beneficio en quienes Genen un componente claramente alérgico, como en este caso, las recomendaciones más recientes no los recomiendan en adultos, por su alta tasa de efectos adversos, incluyendo patología psiquiátrica grave (hoy únicamente se aceptan en niños, advirGendo los riesgos). Por ello, dejaremos como respuesta correcta el aumento de la dosis de corticoides, aunque probablemente lo correcto en el Eunacom fue agregar un inhibidor de leucotrienos, por ser una pregunta más antigua.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 15 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Paciente de 30 años con tos nocturna y disnea de esfuerzo. Espirometría basal normal. Se realiza test de provocación con metacolina: caída del VEF1 del 22% con dosis de 8 mg/mL. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Asma bronquial
B) EPOC
C) Bronquiectasias
D) Fibrosis pulmonar
E) Bronquiolitis obliterante

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Caída del VEF1 ≥20% con metacolina = hiperreactividad bronquial = test positivo para asma. Es el gold standard cuando la espirometría basal es normal.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 17 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

Paciente de 25 años con tos y sibilancias recurrentes. Espirometría muestra VEF1/CVF 68% (< 70%), VEF1 72% del predicho. Post broncodilatador: VEF1 aumenta 15% y 220 mL. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Asma bronquial
B) EPOC leve
C) Bronquiectasias
D) Fibrosis pulmonar idiopática
E) Traqueomalacia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Obstrucción espirométrica + prueba broncodilatadora positiva (aumento VEF1 ≥12% y ≥200 mL) = asma bronquial. La reversibilidad distingue asma de EPOC.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 22 1.05.1.003 · Asma bronquial leve y mode

¿Cuál de las siguientes sustancias es una causa frecuente de asma pulmonar por ex- posición laboral?

A) Asbesto
B) Sílice
C) Harina
D) Algodón
E) Carbón

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Asbesto, sílice y carbón producen neumoconiosis. La inhalación de harina, produ- ce asma y es la causa más freucuente de asma laboral.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 21 1.05.3.003 · Programa Nacional de Contr

Un paciente de 32 años, lleva un año conviviendo con pacientes bacilíferos, se en- cuentra asintomático y su radiografía de tórax no muestra alteraciones, se solicita un PPD que resulta en 23 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar tratamiento atibiótico con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambu- tol por 6 meses
B) Repetir PPD en un mes
C) Dar de alta y control en caso de síntomas
D) Solicitar reacción en cadena de polimerasa para mycobacterium tuberculosis en la- vado bronquioloalveolar
E) Indicar isoniazida por 6 meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un contacto, con PPD mayor a 10, por lo que se debe indicar profilaxis antibióti- ca (isoniazida 6 meses es la recomendación del Minsal).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 165 1.05.4.002 · TAC de tórax

Un paciente de 67 años, fumador de 40 paquetes/año presenta tos desde hace 4 meses, con expectoración mucosa y ocasionalmente hemoptoica. Además, ha presentado pérdida de 5 kilogramos peso. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 120/80 mmHg y se observa hipocratismo digital. Al examen pulmonar disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho y crépitos en la misma zona. ¿Cuál es el examen diagnóstico más adecuado para comenzar el manejo?

A) PET-TC
B) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para tuberculosis y cultivo para micobacterias
C) Fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar
D) TAC de tórax
E) Resonancia magnética de tórax

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Evaluación Inicial del Cáncer Pulmonar: En un paciente con sospecha de cáncer pulmonar, el examen inicial recomendado es una radiografía de tórax. La tomografía computarizada de tórax también proporciona información muy valiosa y, ante una alta sospecha, se puede pedir como examen inicial. Sin embargo, la radiografía se sigue considerando como el examen inicial.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 58 1.05.4.002 · TAC de tórax

Hombre de 60 años con tos de 3 meses de evolución y baja de peso. La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha. ¿Cuál es el siguiente examen a solicitar?

A) Resonancia magnética de tórax
B) Radiografía de tórax lateral
C) TAC de tórax con contraste
D) Cintigrafía ósea
E) Ecografía de tórax

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Masa pulmonar sospechosa en Rx de tórax: el siguiente paso es TAC de tórax con contraste para caracterizar la lesión (tamaño, morfología, densidad, adenopatías mediastínicas). Es imprescindible para estadificación y planificación de biopsia. La Rx frontal ya fue realizada.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 112 1.05.4.002 · TAC de tórax

Un paciente de 68 años, con antecedente de EPOC, fumador de 30 paquetes año, consulta por cuadro de 3 días de hemoptisis escasa, asociada a dificultad respiratoria. Tiene antecedente de hernioplastía hace 7 días. Al examen físico su frecuencia cardiaca es de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto, presión arterial 120/80mmHg, saturación arterial 95% con FiO2 ambiental. Su examen pulmonar mues- tra murmullo presente bilateral con escasas sibilancias. ¿Cuál es el examen más ade- cuado para proseguir con su estudio?

A) TAC de tórax
B) Cintigrafía V/Q
C) Angiografía pulmonar
D) Ecocardiograma
E) AngioTAC de tórax

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (AngioTAC de tórax). La sospecha es un TEP, que se estudia preferentemente con angioTAC de tórax.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 14 1.05.4.002 · TAC de tórax

Un paciente de 45 años vive en situación de marginalidad y hacinamiento, tiene antecedente de alcoholismo y tabaquismo activos; consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de tos con expectoración mucopurulenta, que, en ocasiones, es hemoptoica. También, ha presentado fiebre intermitente, ha bajado de peso cerca de 4 kilogramos y refiere sudoración, que es mayor en la mañana y en la noche. Al examen físico tiene T°: 37,6°C, FC: 83x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x', auscultación pulmonar con crepitaciones pulmonares bilaterales, mayores en el lóbulo superior izquierdo y auscultación cardíaca normal. Se tomaron dos baciloscopías, que resultaron negativas y se solicitó una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: https://urgenciasbidasoa.wordpress.com): ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio de este paciente?

A) Reacción en cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis
B) PPD (prueba de tuberculina)
C) TAC de tórax
D) Lavado bronquioalveolar
E) Ensayo de liberación de interferón gama

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (TAC de tórax). El tabaquismo es un factor de riesgo mayor con implicaciones cardiovasculares (ACV, infarto, claudicación intermitente, aneurisma de aorta abdominal), oncológicas (cáncer de pulmón, boca, vejiga, lengua, nariz, esófago, laringe) y respiratorias (EPOC, enfisema pulmonar, bronquitis crónica). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 164 1.05.5.002 · Biopsia pleural

Un paciente de 80 años, consulta por cuadro de disnea de un mes de evolución que ha aumentado en el último tiempo, asociado a baja de peso. Al examen físico presenta disminución del murmullo pulmonar en el hemitórax izquierdo con matidez a la percu- sión. Se solicita radiografía de tórax que muestra presencia de derrame pleural dere- cho, el que se punciona, dando salida a un líquido pleural con LDH de 300mg/dL, coles- terol 60mg/dL, ADA 15 UI, leucocitos 3.000/mm3 con predominio mononuclear. El exa- men de elección para proseguir con el diagnóstico es:

A) Broncoscopía
B) Videotoracoscopía
C) Ecografía pleural
D) Ecocardiografía
E) TAC de tórax

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un exudado pleural mononuclear y por tanto se debe biopsiar. Una forma nue- va de hacer la biopsia es la videotoracoscopía, que tiene más sensibilidad y si está dis- ponible, puede ser de mayor utilidad que las biopsias percutáneas (que no aparecían).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 171 1.05.4.007 · Citoquímico de líquido ple

Un paciente de 40 años, consulta por disnea desde hace 2 semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia matidez a la percusión y disminución del murmullo pulmonar en base izquierda. Se realiza radiografía que se muestra a conti- nuación: INSERTAR FOTO El examen más adecuado para seguir con el estudio es:

A) TAC
B) AngioTAC
C) Ecocardiografía
D) Análisis citoquímico del líquido pleural
E) Ecografía pleural

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Análisis citoquímico del líquido pleural). Tiene un derrame pleural, que debe ser puncionado, para analizar el líquido.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 94 1.05.4.007 · Citoquímico de líquido ple

Paciente con derrame pleural unilateral. Se realiza toracocentesis. ¿Cuál es el examen del líquido pleural que permite clasificarlo como exudado o trasudado según los criterios de Light?

A) Proteínas y LDH en líquido pleural y suero
B) Glucosa en líquido pleural
C) ADA en líquido pleural
D) pH del líquido pleural
E) Recuento celular diferencial

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Criterios de Light: proteínas LP/suero >0.5, LDH LP/suero >0.6, LDH LP >2/3 del límite normal = exudado. La presencia de uno o más criterios clasifica como exudado.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 9 1.05.5.009 · Punción pleural

Un paciente de 51 años presenta, desde hace 5 días, un cuadro de disnea, que ha ido en aumento, con compromiso del estado general y fiebre hasta 38°C, asociada a tos y expectoración mucopurulenta. Además, presenta dolor tipo puntada de costado izquierdo. Al examen físico está enflaquecido, tiene PA: 110/70 mmHg, FC: 96x', FR: 28x', satura 91% a FiO2 ambiental. En el examen pulmonar se aprecia disminución del murmullo pulmonar en la base izquierda, asociados a estertores bilaterales. Se solicita un hemograma que muestra blancos: 15.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3 y hematocrito: 38% y una radiografía de tórax, que se muestra a continuación. Foto 2 (https://www.neumosur.net/files/EB04-24%20XXXXXXX%20XXXXXX.pdf) ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Solicitar baciloscopías de desgarro
B) Realizar cirugía
C) Solicitar ecografía de tórax
D) Solicitar TAC de tórax
E) Realizar toracocentesis evacuadora y diagnóstica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un derrame pleural izquierdo, por lo que se debe evacuar y estudiar. La clínica orienta a nuemonía o tuberculosis, sin dejar claro cuál es la causa.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 124 1.05.5.009 · Punción pleural

Un paciente de 43 años, con antecedentes de tabaquismo y consumo excesivo de alcohol, consulta por un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y en ocasiones hemoptoica. Al examen físico, se observa delgado, con T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca: 100x', PA: 118/76 mmHg, saturación arterial de 95% y frecuencia respiratoria: 17x'. Su examen pulmonar muestra crepitaciones y algunos estertores bilaterales y su examen cardíaco muestra ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar una prueba de quantiferón para tuberculosis
B) Realizar una broncoscopia
C) Solicitar una prueba de elisa de cuarta generación para VIH
D) Realizar una toracocentesis diagnóstica y evacuadora
E) Solicitar una tomografía axial computarizada (TAC) de tórax

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Derrame Pleural: El cuadro clínico sugiere una tuberculosis activa en la infección inicial o bien una neumonía bacteriana, en ambos casos con derrame pleural izquierdo visible en la radiografía. La toracentesis diagnóstica y evacuadora es la medida más importante. Se debe solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis o, al menos, baciloscopías. El quantiferón-TB solo es útil para la tuberculosis latente, que no se sospecha en este caso al haber síntomas.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 120 1.05.5.009 · Punción pleural

Un paciente de 30 años, cuyo hermano está en tratamiento antituberculoso, en la fase bisemanal, presenta tos y expectoración mucopurulenta, asociada a fiebre de 38,7°C, desde hace 7 días. Se inició amoxicilina al inicio de los síntomas, con buena respuesta inicial, sin embargo, luego recurren los síntomas. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: La conducta más adecuada es;

A) Agregar ácido clavulánico al tratamiento
B) Solicitar TAC de tórax
C) Solicitar PPD
D) Iniciar tratamiento antituberculoso
E) Realizar estudio de líquido pleural

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discutible, sin embargo, la radiografía muestra únicamente un derrame pleural izquierdo y, por tanto, se debe puncionar y estudiar. Además, queda la duda si se trata de un derrame tuberculoso o de otra causa, ya que respondió parcialmente a la amoxicilina y tiene una clínica aguda, sugerente de neumonía bacteriana, por lo que podría ser paraneumónico. Finalmente, el manejo de los contactos de tuberculosis, se hace apenas se diagnostica el caso y no cuando ya está en la fase bisemanal, en que ya no contagia (además que el estudio de los contactos es con BK y RxTx).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 10 1.05.1.022 · Infecciones de las vías aé

Un paciente de 38 años consulta por malestar general y fiebre de 3 días de evolución, asociada a mialgias, tos seca y rinorrea mucosa abundante. Al examen físico tiene secreción nasal y faringe congestiva y eritematosa. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de este paciente?

A) Amoxicilina
B) Aciclovir
C) Acetaminofeno
D) Claritromicina
E) Prednisona

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una influenza u otra infección respiratoria alta, por lo que se trata con paracetamol o acetaminofeno.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 99 1.05.2.005 · Embolia pulmonar masiva

Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral. Desde hace 2 meses está en quimioterapia por cáncer de colon. Hoy presenta un síncope luego de levantarse de la cama y se asocia a disnea y dolor torácico. Su FC: 120x', PA: 90/50 mmHg, FR: 32x' y saturación de oxígeno: 93%. Su examen pulmonar es inespecífico. Se solicita electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama derecha, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?

A) Radiografía de tórax
B) TAC de tórax
C) Dímero D
D) Ecocardiograma
E) AngioTAC de tórax

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un TEP masivo (compromiso hemodinámico), por lo que se estudia con ecocardiograma (para evaluar la disfunción del ventrículo derecho), y no con el angioTAC (de elección en el TEP no masivo).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 8 1.05.2.005 · Embolia pulmonar masiva

Un paciente de 60 años, fumador de 20 paquetes-año y con antecedente de trombosis venosa profunda hace 10 años, presenta un cuadro de disnea y malestar general de 7 días de evolución, que empeoró súbitamente hace unas horas, presentando un síncope con recuperación posterior. Al examen Fsico destaca presión arterial 70/40 mmHg, frecuencia cardíaca 150 lpm, frecuencia respiratoria 40 rpm y saturación de oxígeno de 86%. Se observa ingurgitación yugular y se constata que está desorientado. Se solicita un electrocardiograma, que muestra una taquicardia sinusal y se realiza un AngioTAC, que muestra defectos de llenado en ambas arterias pulmonares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Trombólisis con tenecteplase
B) Trombólisis con estreptoquinasa
C) Heparina endovenosa
D) Trombectomía abierta quirúrgica
E) Trombectomía intraarterial con catéter

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un probable cáncer de pulmón, complicado con un TEP masivo (inestabilidad hemodinámica, compromiso de conciencia), cuyo tratamiento de elección es la trombólisis sistémica (se prefieren los trombolíticos modernos sobre la estreptoquinasa). Si la trombólisis está contraindicada (ej. hemorragia grave), se procede a la embolectomía generalmente abierta. En cambio, en el TEP no masivo no se tromboliza, sino solo se anticoagula. Comentario aparte, el examen de elección no era el angioTAC, sino el ecocardiograma de urgencia, que confirma el TEP masivo si hay signos de hipertensión pulmonar.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 38 1.05.1.029 · Neumonías en inmunosuprimi

Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Fibrosis pulmonar
B) Asma bronquial
C) Neumonitis viral
D) Neumonía por mycoplasma
E) Neumonía por Pneumocystis jiroveci

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, pero que esté enflaquecido más el cuadro clínico, hace que se trate de una neumonía por P. jiroveci. Si hubiese venido sin mayores antecedentes y con un cuadro un poco más corto, sin baja de peso, habría que pensar en Mycoplasma, que puede ser igual. La fibrosis y el asma serían cuadros más crónicos, con radiografías distintas (panal de abejas en fibrosis y normal o hiperinsuflación en asma). La neumonitis viral es aguda.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 165 1.05.1.001 · Absceso pulmonar

Un paciente alcohólico, fumador de 10 paquetes año, presenta, desde hace 7 días, un cuadro de tos, con expectoración purulenta y fiebre hasta 38°C. Ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas. Al examen físico está febril, con apremio respiratorio. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Broncoscopía
B) Videotoracoscopía
C) TAC de tórax
D) PET-TC
E) Resonancia magnética nuclear de tórax

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un absceso pulmonar gigante. El manejo es discutible, pero la TAC podrá identificarlo mejor y descartar que haya un cáncer debajo. La broncoscopía también aparece como una opción aceptable, ya que permitiría el drenaje, pero la TAC igualmente debe solicitarse antes y, además, el tratamiento suele ser con clindamicina endovenosa, más drenaje postural, por lo que la broncoscopía solo se hace si falla.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 93 1.05.1.032 · Neumotórax pequeño

Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico derecho, de 2 días de evolución, que aumenta con la inspiración y con la actividad física. Al examen físico está eupneico, con FR: 15x', saturación de oxígeno normal, se aprecia disminución del murmullo pulmonar mayor en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (Fuente: imgur.com): ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control radiológico en 24 horas
B) Solicitar TAC de tórax
C) Realizar cirugía abierta
D) Drenaje con tubo pleural
E) Realizar videotoracoscopía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, ya que no se ve bien la radiografía (en el Eunacom original era muy difícil verlo), pero tiene clínica de un neumotórax espontáneo. El manejo es con tubo pleural, pero en los casos en que no hay colapso pulmonar, es posible observarlo, darle analgesia y controlarlo con nuevas radiografías. En este caso, que lleva 2 días sin agravarse, lo más correcto es controlar con radiografía en 24 horas.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 152 1.05.1.036 · Tuberculosis pulmonar

Un paciente de 42 años consulta por tos de un mes de evolución, sin expectoración. Su esposa está en tratamiento antituberculoso. Su examen físico muestra crépitos escasos bilaterales. Se realizaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; quantiferón para tuberculosis, que resulta positivo; y radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): La conducta más adecuada es:

A) Iniciar profilaxis antituberculosa
B) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
C) Iniciar tratamiento antibiótico antituberculoso
D) Solicitar cultivo de Koch
E) Solicitar PPD

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un paciente contacto estrecho y sintomático, que, además, ya tiene una prueba positiva para tuberculosis (el quatiferón). Por tanto, aunque tenga las baciloscopías negativas se debe iniciar el tratamiento y no es necesario pedir la PCR.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 159 1.05.2.006 · Enfermedad bronquial obstr

Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x', PA: 110/76 mmHg, FC: 110x' y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesoria, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Su radiografía de tórax se muestra más abajo (fuente: radiopaedia). Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo antibióticos y nebulizaciones con broncodilatadores por una hora, sin mejoría clínica. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaCO2: 62 mmHg, PaO2: 56 mmHg, pH:7,29 y HCO3: 27 mEq/L. La conducta más adecuada, a continuación, es:

A) Ventilación mecánica invasiva
B) Aminofilina endovenosa
C) Oxígeno por cánula nasal de alto flujo
D) Ventilación no invasiva
E) Bicarbonato de sodio endovenoso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un EPOC descompensado. Además, por tener hipercarbia mayor a 50, está indicado el apoyo ventilatorio, en este caso no invasivo, por no tener compromiso de conciencia. Los gases muestran una insuficiencia respiratoria global (02 < 60 y CO2 > 49), que per sé también se ventila.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 13 1.05.2.006 · Enfermedad bronquial obstr

Una paciente de 72 años, con antecedente de EPOC, con hábito tabáquico suspendido hace 5 años y que, además tiene antecedente de diabetes e hipertensión arterial, consulta por un cuadro de 7 días de aumento de la disnea basal, la que se ha vuelto de pequeños esfuerzos y se ha asociado a mayor tos y expectoración, a lo que se ha agregado sensación febril. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca de 105x', presión arterial de 148/92mmHg, respiración a 37 por minuto, saturación de oxígeno por pulsometría de 87%. La auscultación cardíaca muestra ruidos apagados y el examen pulmonar demuestra aumento del diámetro torácico, con disminución bilateral del murmullo vesicular, asociada a sibilancias, roncus y escasos crépitos bilaterales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: https://campuskinesico.com): Se inician nebulizaciones con salbutamol, más corticoides y antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa y oxígeno por mascarilla al 24%. A la hora siguiente, continúa con apremio respiratorio y taquipnea con examen físico en condiciones similares, además, se reciben los resultados de gases arteriales, que muestran lo siguiente: PaO2: 56 mmHg, PaCO2: 62 mmHg, bicarbonato: 21 mEq/L y pH: 7,26. ¿Cuál es la conducta es más adecuada?

A) Oxígeno por mascarilla al 50%
B) Ventilación mecánica invasiva
C) Ventilación mecánica no invasiva
D) Teofilina endovenosa y nebulizaciones con formoterol
E) Solicitar TAC de tórax

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Oxígeno por mascarilla al 50%** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 88 · 1.05.1.020 · Hidatidosis pulmonar

Paciente con expectoración hemoptoica y eliminación de contenido 'en uvas'. Radiografía con imagen compatible. ¿Diagnóstico más probable?

A) Quiste hidatídico pulmonar
B) Absceso pulmonar
C) Bronquiectasias
D) Cáncer pulmonar cavitado
E) Aspergilosis pulmonar invasiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Quiste hidatídico pulmonar** (opción **A**). Quiste hidatídico pulmonar. Esta clase revisa las infecciones oportunistas del VIH. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 11 · 1.05.1.020 · Hidatidosis pulmonar

Un paciente de 42 años presenta tos seca de 7 días de evolución que hace 3 días se volvió produc8va, con secreción de sabor salado. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 68 lpm, presión arterial 120/80 mmHg y frecuencia respiratoria 16 rpm. El examen pulmonar muestra ma8dez en la zona inferior del campo pulmonar derecho, con disminución del murmullo pulmonar en dicha zona. Los exámenes de laboratorio revelan un hematocrito: 38%, plaquetas: 312.000 por mm³, y glóbulos blancos: 12.000 por mm³, con 10% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Derrame pleural tuberculoso
B) Hida2dosis pulmonar
C) Absceso pulmonar
D) Neumonía
E) Carcinoma broncogénico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una hidaGdosis clásica, con el cuadro clínico de “vómica”, característica del quiste hidaVdico pulmonar roto. El no roto suele ser asintomático. El examen de elección es la radiografía de tórax y, luego, se debe seguir el estudio con una TAC para precisar las características del quiste. El tratamiento del quiste hidaVdico incluye albendazol oral por 1 a 3 meses, seguido de un procedimiento invasivo. En el caso del pulmonar se debe operar, en cambio, en los hepáticos rara vez se operan y se manejan con inyección de alcohol.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 56 · 1.05.1.020 · Hidatidosis pulmonar

Un paciente de 43 años, trabajador agrícola, consulta por un cuadro de tos, asociada a expectoración abundante líquida, con salida de membranas que parecen hollejos de uva. Su signos vitales están dentro de rango normal y su examen pulmonar muestrea murmullo pulmonar presente, con escasos estertores en el lado izquierdo. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculoma
B) Aspergiloma
C) Cáncer pulmonar
D) Absceso pulmonar
E) Hidatidosis pulmonar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Aspergiloma** (opción **B**). Esta clase revisa las infecciones oportunistas del VIH. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 160 · 1.05.1.035 · Tos crónica

Un paciente de 36 años consulta por sensación de opresión precordial y tos, que son más intensas en la noche. Además, refiere disfonía y rinorrea, que se exacerbó durante la primavera. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar omeprazol oral
B) Iniciar antihistamínicos orales
C) Iniciar corticoides orales
D) Iniciar antibióticos orales
E) Iniciar AINEs orales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar antihistamínicos orales** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 145 · 1.05.5.012 · Ventilación mecánica no in

Paciente con EPOC exacerbado con pH <7,30 y pCO2 >49 mmHg tras O2, broncodilatadores, antibióticos y corticoides. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Intubación orotraqueal e inicio de VMI
B) Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP)
C) Aumentar FiO2 a 60%
D) Heliox y magnesio endovenoso
E) Traslado a UCI sin cambiar manejo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP)** (opción **B**). Ventilación mecánica no invasiva (VNI/BIPAP). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 163 1.05.5.012 · Ventilación mecánica no in

Un paciente de 72 años, con antecedente de tabaquismo de 50 paquetes/año, complicado con enfermedad pulmonar obstruc8va crónica severa en tratamiento con salmeterol y flu8casona inhalados, presenta aumento de su tos y disnea desde hace 3 días, agregándose expectoración mucopurulenta y fiebre hasta 38,4 °C. Luego evoluciona con marcado aumento de su disnea, la que se vuelve de reposo. Al examen Fsico se observa agitado, orientado en 8empo y espacio, disneico, con uso de musculatura accesoria, frecuencia respiratoria: 40 rpm, saturación de oxígeno: 84%, frecuencia cardíaca: 108 lpm y presión arterial: 146/92 mmHg. El examen pulmonar muestra aumento del diámetro torácico, hipersonoridad a la percusión, sibilancias y roncus bilaterales difusos, con algunos crépitos más intensos en el lado derecho. Los gases arteriales muestran: PaO_2: 65 mmHg, $PaCO_2$: 55 mmHg, HCO_3^-: 28 mEq/L, pH: 7,29. Su hemograma muestra hematocrito: 50%, hemoglobina: 17 g/dL, plaquetas: 380.000/mm³ y glóbulos blancos: 14.500/mm³. Se inicia nebulización con broncodilatadores y se administran an8bió8cos y cor8coides por vía endovenosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo respiratorio?

A) Oxígeno por mascarilla Venturi al 50%
B) Oxígeno por mascarilla de no recirculación
C) Oxígeno por naricera al 24%
D) Oxígeno por cánula nasal de alto flujo a 15 L/min
E) Ven2lación mecánica no invasiva

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene hipercarbia, por lo que requiere ventilación mecánica. La regla general es que sea no invasiva (VMNI), a menos que no la tolere o que tenga encefalopaVa, casos en los que se maneja con ventilación mecánica invasiva (VMI). El punto de corte de la PaCO2 es 50 mmHg, aunque se debe considerar desde los 45 mmHg, especialmente si está encefalópata o con hipoxia.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 7 1.05.4.001 · Radiografía de tórax

IMAGEN: Persona en situación de calle con hemitórax radiopaco: a. Derrame pleural masivo

A) Derrame pleural
B) Neumotórax
C) Neumonía
D) Atelectasia
E) Masa pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Derrame pleural). El derrame pleural puede ser asintomático o presentarse con disnea y dolor pleurítico. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 135 1.05.5.005 · Fibrobroncoscopia

Cáncer vs TBC, tenia baja de peso, hipocratismo digital ¿Cuál es el exámen a realizar? a. TC con contraste b. Broncoscopía tb

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 10 1.05.2.010 · Intoxicación por monóxido

Un paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y sensación de opresión precordial, 3 horas después de haber estado expuesto a humo durante un incendio en su casa. Al examen Fsico registra frecuencia cardíaca 100 lpm, presión arterial 130/85 mmHg, frecuencia respiratoria 35 rpm y saturación de oxígeno de 96%. No presenta cianosis ni uso de musculatura accesoria, y su examen cardiopulmonar es normal. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?

A) Radiogra:a de tórax
B) TAC de tórax
C) Niveles de carboxihemoglobina
D) Gases en sangre arterial
E) Monitorización transcutánea de niveles de anhídrido carbónico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es una intoxicación por monóxido de carbono. La saturación de oxígeno es falsamente normal en la oximetría de pulso. Los gases arteriales suelen ser normales, ya que la PaO2 no se altera, sino que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno en la hemoglobina. Tampoco Genen cianosis (“muertos rosados”). El examen diagnóstico de elección es la medición de carboxihemoglobina. El tratamiento de elección es el oxígeno al 100%. La terapia hiperbárica, además, está indicada si la carboxihemoglobina es mayor a 25% (20% en embarazo) o si hay compromiso de conciencia.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 41 · 1.05.2.010 · Intoxicación por monóxido

Una paciente de 25 años fue encontrada inconsciente por su pareja en el baño de su casa, por lo que es llevada de inmediato al servicio de urgencias. Al examen físico, presenta escala de Glasgow: 15 puntos, tiene presión arterial: 110/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 115 lpm, frecuencia respiratoria: 12 rpm y saturación de oxígeno: 98%. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 98 mg/dl y carboxihemoglobina: 20%. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Administrar oxígeno por naricera de alto flujo
B) Solicitar una TAC de cerebro
C) Realizar terapia hiperbárica
D) Administrar broncodilatadores por vía inhalada
E) Administrar oxígeno por mascarilla de no recirculación

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Intoxicación por Monóxido de Carbono: El cuadro clínico apunta a una intoxicación por monóxido de carbono, donde la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno permanecen normales. Por ello el diagnóstico se confirma con la carboxihemoglobina, que en este caso está elevada. El tratamiento inicial consiste en administrar oxígeno al 100% con alto flujo, mediante una mascarilla sin recirculación para acelerar la eliminación del monóxido de carbono (el oxígeno compite contra el monóxido de carbono en su unión a la hemoglobina). En casos graves (carboxihemoglobina > 25%), se recomienda, además, la terapia hiperbárica.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 144 · 1.05.2.010 · Intoxicación por monóxido

Paciente encontrada en el baño, tenía carboxiHb de 12% tto de elección:

A) O2 mascarilla
B) Cámara hiperbarica
C) Ninguna de las anteriores es correcta
D) Todas las anteriores son correctas
E) No se dispone de información suficiente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (O2 mascarilla). La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una emergencia médica potencialmente letal que requiere reconocimiento y manejo rápido. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 156 · 1.05.1.011 · Derrame pleural paraneumón

Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y fiebre de hasta 38,7°C. El examen físico muestra disminución del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax muestra signos de condensación en el lado derecho y derrame pleural de tamaño moderado Se inicia tratamiento con ceftriaxona 2g al día y se realiza toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural con 2.000 células/mm3, 85% de polimorfonucleares, colesterol: 70 mg/dL, LDH: 220 U/L, pH: 7.26 y lactato de 6.1 mmol/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar drenaje completo del derrame pleural
B) Agregar metronidazol al tratamiento
C) Solicitar TAC de tórax
D) Solicitar baciloscopías de expectoración
E) Realizar broncoscopia y biopsia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Neumonía con Derrame Paraneumónico: El manejo de una neumonía con derrame paraneumónico complicado (por el lactato pleural > 5 mmol/L) incluye drenaje completo del derrame pleural (medida más importante), tubo pleural y metronidazol para cubrir bacterias anaerobias.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 179 · 1.05.2.004 · Crisis de asma bronquial

Un paciente de 25 años, con antecedente de asma en tratamiento con flu8casona, un puff cada 12 horas, y salbutamol SOS, consulta por un cuadro de disnea que inició hace 48 horas en relación a un cuadro respiratorio alto y que ha ido empeorando, presentando actualmente disnea de mínimos esfuerzos que no ha respondido al uso de salbutamol. Al examen Fsico se observa taquipneico, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, frecuencia respiratoria de 35 por minuto, saturación de oxígeno 95% y frases con palabras entrecortadas. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para precisar la severidad del cuadro?

A) Radiogra:a de tórax
B) Test de metacolina
C) Flujo espiratorio máximo (PEF)
D) Hemograma y VHS
E) Gases en sangre venosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La severidad de la crisis asmática se determina en base a la clínica. Dentro de los exámenes, son úGles tanto el PEF como los gases en sangre arterial (no venosa, ya que la PaO2 arterial es el parámetro que define el manejo) y suelen pedirse ambos. El PEF suele ser el inicial y más importante para objetivar y seguir el grado de obstrucción y respuesta al tratamiento. Los GSA se solicitan especialmente cuando la crisis es muy severa y hay signos de insuficiencia respiratoria. Los GSA son mucho más importantes en el EPOC descompensado, en que Gende a la hipercarbia y definen la necesidad de ventilación mecánica. En el asma, en cambio, la clínica y el PEF muchas veces son suficientes.

NEFROLOGÍA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 05

56 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

25 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.09.1.001	Acidosis e hiperkalemia en Insuficiencia renal crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 3.3 (Pág. 37)
1.09.1.006	Glomerulopatía lúpica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · 4.5 (Pág. 58)
1.09.1.007	Hipernatremia, poliuria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 2.3 (Pág. 24)
1.09.1.009	Hipertensión arterial secundaria	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 05 · 5.3 (Pág. 69)
1.09.1.010	Hiponatremia crónica asintomática	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 2.2 (Pág. 22)
1.09.1.013	Nefritis intersticial no infecciosa (aguda o crónica)	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9)
1.09.1.014	Nefropatía diabética	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63)
1.09.1.015	Osteodistrofia en insuficiencia renal crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · 5.2 (Pág. 67)
1.09.1.016	Pielonefritis aguda no complicada	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71)
1.09.1.018	Proteinuria	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8)
1.09.1.020	Edema generalizado (anasarca)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · 1.4 (Pág. 13)
1.09.1.021	Síndrome nefrítico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 05 · 4.3 (Pág. 52)
1.09.1.022	Síndrome nefrótico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 05 · 4.1 (Pág. 46)
1.09.1.024	Urolitiasis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8)
1.09.2.004	Enfermedad tubular aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 05 · 1.2 (Pág. 9)
1.09.2.005	Hiperkalemia grave	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 05 · 3.1 (Pág. 31)
1.09.2.006	Hipokalemia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · 3.2 (Pág. 35)
1.09.2.007	Hiponatremia aguda grave	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 05 · 2.1 (Pág. 18)
1.09.2.008	Hipovolemia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5)
1.09.2.010	Insuficiencia renal aguda prerrenal	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 1.1 (Pág. 5)
1.09.2.011	Pielonefritis aguda complicada	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · 5.4 (Pág. 71)
1.09.2.013	Vasculitis o glomerulonefritis rápidamente progresiva	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 4.4 (Pág. 54)
1.09.3.009	Terapia diurética	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 05 · 2.4 (Pág. 26)
1.09.3.011	Trasplante renal, indicaciones y complicaciones	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · Nefrología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.09.4.005	**Ecografía renal (tamaño, asimetrías, hidronefrosis)**	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 05 · 5.1 (Pág. 63)

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 10 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Hombre de 35 años sin antecedentes previos consulta por edema facial al despertar, orina espumosa y aumento de peso de 5 kg en 2 semanas. Proteinuria 24h: 8 g. Albúmina 2.0 g/dL. Sin hematuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome nefrótico puro
B) Síndrome nefrítico agudo
C) Glomerulonefritis membranoproliferativa
D) Nefropatía IgA
E) Pielonefritis crónica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Proteinuria masiva (>3.5 g/24h) + hipoalbuminemia + edema + sin hematuria = síndrome nefrótico puro. En adulto joven sin causa secundaria, la causa más frecuente es nefropatía por cambios mínimos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 14 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Una paciente de 34 años, diabética con control metabólico irregular, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2% y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. ¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?

A) Electroforesis de proteínas en sangre
B) Biopsia renal
C) Inmunofijación de proteínas en orina
D) Prednisona oral
E) ANCA, C3 y C4

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy difícil, pero tiene un claro síndrome nefrótico, que, por estar en contexto de una diabetes, se sospecha sea por nefropatía membranosa. Por ser una mujer joven, también podría ser un lupus, con nefropatía membranosa. De las opciones, solo la biopsia renal serviría para avanzar en el diagnóstico. Sí hay que solicitar ANA y complemento (no ANCA, ya que las vasculitis son nefríticas).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 121 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Paciente 36 años, sin antecedentes de importancia, cursa con un cuadro de un mes de evolución de edema de EEII que posteriormente se agrega edema bipalpebral que aparece en las mañanas. Al examen físico, presenta FC: 96'x, TA: 130/70 mmHg, se constata edema de miembros inferiores, en ambos tobillos, que asciende hasta la pierna. Se solicitan exámenes de laboratorio, que muestran creatininemia 1,7 mg/dl, BUN 20 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, examen de orina con densidad: 1020 g/L, glucosuria (-), nitritos (-), proteínas (++), eritrocitos: 2-3 x campo, leucocitos 3-5 x campo. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome nefrítico
B) Síndrome nefrótico
C) Síndrome cardiorrenal
D) Injuria renal aguda
E) Hiperaldosteronismo primario

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome nefrótico clásico (proteinuria, edema, hipoalbuminemia). No hay hematuria ni HTA, así que no puede ser nefrítico.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 154 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Un paciente de 33 años, hospitalizado por una endocarditis subaguda por estrepto- cocus víridans, en tratamiento con penicilina y gentamicina por vía endovenosa, pre- senta un cuadro de hematuria de algunos días de evolución. Se solicita sedimento de orina que muestra 50 glóbulos rojos por campo con 95% de dismorfia y presencia de ci- lindros hemáticos, creatinina de 2,4mg/dL, ANA (-), fracción C3 del complemento de 53mg/dL (valor normal: 75-135 mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embolias renales a repetición
B) Nefritis intersticial secundaria al uso de penicilina
C) Daño tubular agudo secundario al uso de gentamicina
D) Glomerulonefritis por depósito de complejos inmunes
E) Síndrome hemolítico urémico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una glomerulonefriris (por la hematuria dismórfica), asociada a EBSA (por complejos inmunes), por la hipocomplementemia.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 59 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Una paciente de 27 años, diabética tipo 1, con mal control metabólico, consulta por edema de las extremidades inferiores y orinas espumosas. Al examen físico se constata edema palpebral y facial, edema blando de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada de 8,2%, ANA negativos, sedimento de orina con abundantes cuerpos ovales grasos, 2-3 glóbulos rojos por campo y 2-4 glóbulos blancos por campo, creatinina: 1,2 mg/dl y proteinuria cuantitativa de 9 g en 24 horas. ¿Cuál es la conducta de elección para proseguir el manejo de esta paciente?

A) Electroforesis de proteínas en sangre
B) Biopsia renal
C) Inmunofijación de proteínas en orina
D) Prednisona oral
E) Solicitar ANCA, C3 y C4

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome nefrótico clásico. Por ser diabética, lo más probable es que sea una glomerulopatía membranosa. El estudio del síndrome nefrótico incluye todos los exámenes de sangre, en busca de otras causas (ANA, complemento, VIH, virus hepatitis ByC más exámenes generales) y luego la biopsia renal. En este caso, los ANCA, que son marcadores de vasculitis, no se asocian asíndrome nefrótico, sino solo nefrítico y GNRP, por lo que la respuesta que incluye los ANCA no parece correcta.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 26 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Un paciente de 62 años presenta edema de extremidades inferiores, asociada a malestar general y aumento de volumen facial. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 120/80 mmHg, edema de párpados y de extremidades inferiores, con signo de la fóvea. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 147 mg/dl, hemoglobina glicosilada: 6,8%, sedimento de orina con 5 eritrocitos por campo y 2 a 3 leucocitos por campo, proteinuria de 500 mg/dl, colesterol total: 411 mg/dl, albúmina plasmática: 2,1 g/dl y creatinina: 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Nefropatía diabética
B) Nefropatía membranosa
C) Nefropatía lúpica
D) Nefropatía a cambios mínimos
E) Nefropatía por IgA

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome nefrótico clásico (edema, proteinuria, hipoalbuminemia y dislipidemia), que en los adultos suele ser causado por la nefropatía membranosa. Vale la pena mencionar que la proteinuria debe ser mayor a 3 gramos al día y acá solo se dice que es de 500 mg/dl, lo que es muy alto (si hace un litro de orina al día, sería de 5 gramos al día).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 66 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Un paciente de 62 años presenta un cuadro de varios días de evolución, de orinas espumosas, asociado a edema marcado de extremidades inferiores. Su sedimento de orina muestra 2-4 hematíes por campo, 5-10 leucocitos por campo, creatininemia de 1,2 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 7 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nefropatía por IgA
B) Enfermedad renal lúpica
C) Glomerulonefritis postestreptocócica
D) Glomerulonefritis mesangiocapilar
E) Nefropatía membranosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Sd. nefrótico puro en adulto: membranosa. Todas las demás tienen hematuria dismórfica, porque son glomerulonefritis (nefrítico o nefrótico impuro o hematuria aislada).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 3 1.09.1.022 · Síndrome nefrótico

Paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, actualmente hospitalizado por cuadro de edema generalizado en estudio, presenta dolor torácico de inicio súbito, asociado a diaforesis. Al examen físico destaca saturación de 89% con FiO2 ambiental, murmullo pulmonar con crepitaciones difusas bilaterales. En sus exámenes de laboratorio destaca proteinuria de 24 horas de 5gramos, albúmina de 2g/dL y perfil lipídico con triglicéridos de 450 mg/dL. La causa más probable de su dolor torácico es:

A) Neumonía aguda
B) Tromboemolismo pulmonar
C) Infarto agudo al miocardio
D) Pericarditis aguda
E) Disección aórtica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Tromboemolismo pulmonar** (opción **B**). Tiene un síndrome nefrótico, secundario a una neforpatía membranosa y complicado con un TEP. Congénito (menor 3 meses): test genéticos primero, biopsia de entrada, tratamiento = trasplante renal. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 76 1.09.1.014 · Nefropatía diabética

Un paciente de 46 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, acude a control, refiere estar asintomático. Al examen físico se encuentra presión arterial de 138/83, sin otros hallazgos. Sus exámenes de control muestran hemoglobina glicosilada en 6.9%, indice proteinuria creatininuria de 0.3, creatinina 0.8 mg/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Aumentar dosis de metformina
B) Iniciar hidroclorotiazida
C) Iniciar enalapril
D) Suspender metformina e indicar insulina
E) Mantener tratamiento actual y reforzar medidas como dieta y ejercicio

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por la PA (mayor a 130/80 dice la guía antigua, sin embargo la nueva lo deja en 140/90), como por la proteinuria positiva (IP/ C mayor a 0,2 es proteinuria). La proteinuria hace que sea 100% segura la opción de darle los IECAS.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 84 1.09.1.014 · Nefropatía diabética

Diabético con nefropatía, HTA reciente, creatinina 1,5 mg/dL y proteinuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amlodipino
B) Atenolol
C) Hidroclorotiazida
D) Enalapril
E) Losartán

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Enalapril** (opción **D**). Enalapril. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 62 1.09.1.014 · Nefropatía diabética

Un paciente diabético de larga data, en tratamiento con insulina, presenta presión arterial de 148/102. Además su índice proteinuria/creatininuria resulta 0,3. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo de este paciente?

A) Amlodipino
B) Enalapril
C) Carvedilol
D) Hidroclorotiazida
E) Diltiazem

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Enalapril** (opción **B**). Tanto por la HTA, como por la proteinuria se debe iniciar enalapril en el diabético. La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 114 1.09.1.014 · Nefropatía diabética

Un paciente de 62 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 850 mg/8h, hidroclorotiazina 50 mg/día y atenolol 50 mg/día, acude a control. Su presión arterial es 146/100 mmHg, Su examen físico segmentario no aporta mayor información. Trae algunos exámenes, entre los que destacan clearence de creatinina de 48 mililitros por minuto y proteinuria de 500 mg/litro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar amlodipino
B) Agregar doxazosina
C) Agregar enalapril
D) Mantener las indicaciones
E) Reemplazar la hidroclorotiazida por furosemida

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por ser diabético (en HTA), como por la proteinuria, como por tener PA mayor a 130/80 (en falla renal), está indicado iniciar un IECA.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 54 1.09.1.014 · Nefropatía diabética

Un paciente de 50 años, con antecedente de diabetes mellitus, en tratamiento con metformina 1g cada 12 horas y sitagliptina 50 mg cada 12 horas, presenta presiones arteriales de 148/92 mmHg, que se repiten en varios días, con valores entre 140/90 y 150/100. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran creatinina plasmática: 1,5 mg/dl, índice proteinuria/creatininuria: 2,2, electrolitos plasmáticos muestran Na+: 138 mEq/L, K+: 4,2 mEq/L, Cl-: 103 mEq/L; HbA1c: 6,6%. ¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este paciente?

A) Doxasocina
B) Enalapril
C) Hidroclorotiazida
D) Diltiazem
E) Amlodipino

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Hidroclorotiazida** (opción **C**). La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 135 1.09.1.018 · Proteinuria

Paciente de 25 años, deportista, corre una triatlón, luego de esta competencia, para evaluación de dopaje se realiza examen de orina, el cual muestra proteinuria ++, sin presencia de drogas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de su proteinuria?

A) Proteinuria funcional
B) Rabdomiolisis
C) Deshidratación
D) Acidosis metabólica
E) Glomerulopatía membranosa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Proteinuria funcional). Es normal la proteinuria con el ejercicio intenso. No tiene clínica de rabdomiolisis. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 83 1.09.1.021 · Síndrome nefrítico

Una paciente de 21 años, consulta por cuadro de algunos días de evolución de aste- nia, compromiso del estado general y disnea progresiva que actualmente es de mínimos esfuerzos, además ha presentado hematuria. Al examen físico su frecuencia cardiaca es 75 por minuto, con presión arterial 180/110 mmHg. Se aprecia edema facial y de extre- midades inferiores, con signo de la fóvea. Su examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en tres tiempos con presencia de R3 y se auscultan crépitos pulmonares bilate- rales, mayores en ambas bases. Se solicitan exámenes que muestran hematuria dismór-

A) Prednisona vía oral
B) Furosemida endovenosa
C) Bisoprolol vía oral
D) Captopril vía oral
E) Amoxicilina vía oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
B? Tiene un glomerulonefritis aguda postestreptocócica, con un síndrome nefrítico y una insuficiencia cardiaca, por la crisis hipertensiva. Dada la sobrecarga de volumen, la furosemida ev parece ser el tratamiento más razonable, pero el captopril también po- dría ser de utilidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 48 1.09.1.021 · Síndrome nefrítico

Un paciente de 22 años, con antecedente de una amigdalitis bacteriana, hace 2 semanas, con tratamiento antibiótico incompleto, presenta un cuadro de cefalea y orinas espumosas, asociado a edema de extremidades inferiores. Al examen físico, tiene PA: 180/110 mmHg, FC: 62 lpm. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 46 mg/dl, sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con 80% de dismorfia, ANA (-) y proteinuria de 900 mg/24 horas; C3 y C4 bajos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Diuréticos
B) Antiinflamatorios
C) Antibióticos
D) Inmunosupresores
E) Corticoides

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una GNAPE clásica, con la hipocomplementemia característica. Se trata con soporte y diuréticos para el edema y la HTA. Los corticoides solo se indican si hay Sd. Nefrótico asociado o si hay una GNRP. En este caso hay IRA, con una crea de 2, por lo que está al límite de requerir corticoides, pero de las opciones, la de los diuréticos sigue siendo la mejor.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 64 1.09.1.021 · Síndrome nefrítico

Un paciente de 80 años consulta por equimosis periorbitaria, sin antecedente traumático, asociado a astenia y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan creatinina: 2,6 mg/dl, proteinuria de 24 horas: 8,4 gramos/día, albuminemia: 1,4 g/dl. Su hemograma es normal y su VHS: 96 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nefrosis lipoidea
B) Nefropatía diabética
C) Amiloidosis primaria
D) Enfermedad de Berger
E) Arteritis de la temporal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una amiloidosis con compromiso renal (síndrome nefrótico). Orienta a ella la VHS alta y la hipoalbuminemia. Igual es una pregunta muy específica.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 50 1.09.1.021 · Síndrome nefrítico

Un paciente de 30 años, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de rinorrea, tos y disfonía, a lo que se agregó hematuria. Al examen físico presenta frecuencia car- diaca de 80 latidos por minuto, con presión arterial 150/100 mmHg, edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca sedimento de ori- na con 15 leucocitos por campo más incontables eritrocitos con 9% de dismorfia, protei- nuria de 24 horas de 2 gramos y creatinina de 1,7mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Nefropatía por depósitos de IgA
C) Litiasis renal
D) Pielonefritis aguda
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Nefropatía por depósitos de IgA** (opción **B**). Es un Berger clásico.. La glomerulonefritis se diagnostica con sedimento urinario que muestra hematuria dismórfica (acantocitos) o cilindros hemáticos/eritrocitarios. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 148 1.09.1.021 · Síndrome nefrítico

Paciente de 20 años de edad, sin antecedentes, con coriza, tos y odinofagia desde hace dos días manejadas con ibuprofeno, paracetamol y clorfenamina, consulta por aparición de hematuria el día de hoy, asociado a los síntomas antes descritos. Al examen físico presenta presión arterial de 120/70, frecuencia cardiaca normal, resto sin hallazgos patológicos. Se solicita examen de orina que muestra: glóbulos rojos 40-50 por campo con 20% de dismorfismo y cilindros hemáticos. El diagnóstico más probable es:

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Glomerulonefritis lúpica
C) Glomerulonefritis mesangial
D) Glomerulonefritis por IgA
E) Glomerulonefritis por drogas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Enfermedad de Berger con glomerulonefritis aguda, en relación a una infección respiratoria, sin otros síntomas.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 65 1.09.1.021 · Síndrome nefrítico

Un paciente de 32 años presenta un cuadro de dos días de odinofagia, fiebre y mialgias, a lo que se agrega hematuria. En sus exámenes destaca sedimento de orina con incontables glóbulos rojos, con 9% de dismorfia, creatinina plasmática de 0,7 mg/dl, BUN: 13 mg/dl, C3 y C4 en niveles normales y proteinuria de 500 mg/día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nefropatía mesangiocapilar
B) Lupus
C) Glomerulonefritis postestreptocócica
D) Nefropatía por IgA
E) Vasculitis de vaso pequeño

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Complemento normal más hematuria dismórfica. Lúpica, postestreptocócica y mesangiocapilar tienen C3 bajo. Membranosa es solo nefrótica, sin hematuria.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 49 1.09.1.024 · Urolitiasis

Un paciente ha presentado 5 episodios de litiasis uretral en los últimos años. ¿Cuál es la ateración metabólica más probable en este paciente?

A) Hipercalciuria
B) Hiperoxaluria
C) Hiperuricosuria
D) Hipocitraturia
E) Hipercistinuria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La hipercalciuria es la alteración más frecuente en Chile (40 a 50% de los pacientes con litiasis). De todos modos esta es una pregunta ridícula e inútil, que no debería hacerse.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 147 1.09.2.008 · Hipovolemia

Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardiaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156. mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO2: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?

A) Suero glucosado al 5% ev
B) Suero fisiológico al 0,9% ev
C) Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
D) Agua por sonda nasogástrica
E) Sales de rehidratación oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy discutible, pero dado el diagnóstico de deshidratación hipertónica, con marcada hipernatremia e hipecrloremia, da miedo el suero fisiológico (la evidencia no soporta esta recomendación, pero lo habitual es que se crea que el SF puede agravar la hiponatremia). Debería iniciarse suero glucosalino isosmolar, pero no aparece en las opciones. Se pregunta el primer suero a administrar y el suero glucosado parece la única opción aceptable, ya que es hipotónico. Sin embargo, también está la afirmación: “se corrige primero la volemia y luego, nos preocupamos de los electrolitos” y en ese caso sería correcto el SF, ya que con él se logrará corregir la volemia (con SF o Ringer) y luego corregir la natremia (con suero glucosado). Entonces ante la duda, se responde así: ¿Qué pasa si le doy solo suero glucosado?: se muere; y ¿qué pasa si le soy solo suero fisiológico?: tal vez vive. Por tanto, se elige el suero fisiológico.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 31 1.09.2.008 · Hipovolemia

Un paciente de 70 años, diabético tipo 2 e hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida, presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución del volumen urinario. Al examen físico está bradipsíquico, con presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 110x'. En sus exámenes de laboratorio destaca creatinina: 2,0 mg/dl, BUN: 78 mg/dl, FeNa: 0,5%, sodio: 130 mEq/L, potasio: 2,0 mEq/L y cloro: 110 mEq/L . ¿Qué fluido debe administrarse inicialmente?

A) Solución glucosada al 5%
B) Solución ringer lactato
C) Albúmina al 5%
D) Solución glucosalina isotónica
E) Solución de bicarbonato al 2/3 molar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Lo primero en un paciente shockeado siempre es reponer la volemia y luego preocuparse de los electrolitos. La volemia se repone preferentemente con cristaloides (suero fisiológico y Ringer lactato) y en este caso, por la severa hipokalemia es más recomendable el Ringer (aunque no ha demostrado ser mejor que el SF en ninguna situación). Además, no salía SF dentro de las alternativas. La única excepción (aunque sin evidencia que lo demuestre) es la deshidratación hiperosmolar, en que da miedo dar SF, por el riesgo de una mayor hipernatremia (ahí se da suero hipotónico al 0,45% o suero glucosalino: 0,45% NaCl + glucosa 2,5%, aunque insisto que no hay evidencia).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 96 1.09.2.004 · Enfermedad tubular aguda

Un hombre de 32 años presenta dolor muscular y oliguria, 24 horas después de realizar ejercicio intenso, a lo que se agrega malestar general. En sus exámenes destaca creatininemia de 5 mg/dl, uremia de 9 mg/dl y potasemia de 5,4 mEq/L, con natremia: 140 UI/L. ¿Qué examen debe pedirse a continuación?

A) Creatininkinasa
B) Proteinuria de 24 horas
C) Hemograma
D) Sedimento de orina
E) Clearence de creatinina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Creatininkinasa). Parece una rabdomiólisis, que se estudia con CK.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 167 1.09.1.013 · Nefritis intersticial no i

Paciente de 36 años con fiebre y la presencia de una lesión en miembro inferior, en forma de una placa de eritematosa, con bordes definidos de aproximadamente 15 x 8 cm, que responde bien al tratamiento con cloxacilina. Al quinto día comienza con náuseas, vómitos, diuresis adecuada, con leucocitosis de 15.000 por mm3, con 10% de eosinófilos, 40% de neutrófilos y 48% de linfocitos, uremia en 50 mg/dl, creatinina en 3 mg/dl, hematuria microscópica, leucocituria, y proteinuria de 0,8 g/día. Identificar el posible diagnóstico:

A) Glomerulonefritis post estreptocócica
B) Vasculitis de vasos pequeños
C) Injuria renal pre renal
D) Endocarditis infecciosa
E) Nefritis intersticial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una nefritis intersticial clásica, con la eosinofilia característica y la insuficiencia renal, probablemente secundaria al tratamiento farmacológico con la cloxacilina (de base tenía una erisipela).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 133 1.09.1.013 · Nefritis intersticial no i

Un paciente de 27 años presenta una lesión en la pierna derecha, consistente en una placa de 13 por 7 cm de diámetro, eritematosa y solevantada. Se inicia cloxacilina endovenosa. Al quinto día, la lesión cutánea ha mejorado, sin embargo, evoluciona con malestar general, fiebre y aparición de un exantema macular eritematoso, generalizado. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con hematuria microscópica, glóbulos blancos: 20 por campo, hemograma con leucocitosis de 14.000, con 20% de eosinófilos, BUN: 30 mg/dl y creatinina: 2,0 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Vasculitis sistémica primaria
D) Insuficiencia renal aguda prerrenal
E) Nefritis intersticial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una nefritis intersticial clásica, secundaria al uso de antibióticos, en contexto de un síndrome de DRESS (con eosinofilia). La lesión inicial era una erisipela o una celulitis.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 164 1.09.2.013 · Vasculitis o glomerulonefr

Un paciente de 71 años presenta desde hace dos meses malestar general, mialgias y febrícula ocasional, además de episodios de hematuria, especialmente en el úl8mo 8empo. Al examen Fsico, presenta frecuencia cardíaca 82 la8dos por minuto, presión arterial 176/111 mmHg, edema bimaleolar y disminución del volumen de orina. El examen cardiopulmonar muestra ritmo regular en dos 8empos sin soplos y murmullo pulmonar presente con crépitos bibasales, sin otros ruidos. En los exámenes de laboratorio destacan crea8ninemia: 4,34 mg/dL, BUN: 72 mg/dL, sedimento de orina: 10 leucocitos por campo y 60 hema`es por campo, con 10% de acantocitos. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnós8co?

A) An2cuerpos an2nucleares (ANA)
B) Biopsia renal
C) An2cuerpos an2citoplasma de neutrófilos (ANCA)
D) UroTAC
E) Electroforesis de proteínas en orina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene los siguientes diagnósticos: insuficiencia renal aguda, síndrome nefrítico, glomerulonefriGs rápidamente progresiva (GNRP) e hipertensión secundaria. La principal sospecha es una micropoliangeíGs o poliangeíGs microscópica (PAM), que es una vasculiGs grave (alta letalidad sin tratamiento), clásica del adulto mayor. Es ANCA positivo en patrón perinuclear (ANCA-p). Biopsia renal y ANCA aparecen como opciones adecuadas, pero la pregunta específica es el examen adecuado para "confirmar el diagnóstico", por lo que la respuesta correcta es la biopsia renal (examen de elección para el estudio de las GNRP). Sin embargo, es posible que quien redactó la pregunta haya intentado preguntar los ANCA, evaluando la capacidad de identificar el cuadro clínico. Se trata con corticoides sistémicos más rituximab (más usado hoy) o ciclofosfamida. Las recurrencias se evitan con rituximab.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 44 1.09.2.013 · Vasculitis o glomerulonefr

Una paciente de 67 años, presenta un cuadro de malestar general, asociado a febrículas y edema de las extremidades inferiores. Al examen físico, su presión arterial es 180/110 mmHg y se constata el edema blando, con signo de la fóvea. En sus exámenes de sangre destaca creatininemia de 4,1 mg/dl, BUN de 60 mg/dl y sedimento de orina con 60 eritrocitos por campo, con 80% de dismorfia y leucocitos de 10 a 15 por campo y cilindros hemáticos. Su hemograma muestra hemoglobina: 11,8 mg/dl, hematocrito: 36%, blancos: 10.000 por mm3, plaquetas: 160.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glomerulonefritis postestreptocócica
B) Nefropatía diabética
C) Lesión glomerular mínima
D) Vasculitis ANCA positiva
E) Púrpura trombocitopénico trombótico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Vasculitis ANCA positiva** (opción **D**). Es una poliangeítis microscópica clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 48 1.09.4.005 · Ecografía renal (tamaño, a

Un paciente de 28 años, con antecedente de tuberculosis renal a los 16 años, tratada a esa edad, presenta edema blando de extremidades inferiores mayor en las tardes, asociada a hipertensión arterial de 150/90 mmHg. En sus exámenes destaca creatinina plasmática: 2,8 mg/dl, BUN: 40 mg/dl, Na+: 132 mEq/L, K+: 5,0 mEq/L, orina completa con proteinuria ++ y sedimento de orina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio diagnóstico?

A) Pielografía de eliminación
B) Ecografía abdominal
C) Índice proteinuria / creatininuria
D) Cintigrafía DMSA
E) TAC renal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

D?. Tiene una insuficiencia renal recién diagnosticada y para diferenciar una IRA de una IRC, lo más adecuado es la ecografía renal. Sin embargo, la cintigrafía podría ser útil, dado el antecedente de la TBC renal.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 49 1.09.1.010 · Hiponatremia crónica asint

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipotiroidismo, hipertensión y depresión, en tratamiento con levotiroxina, enalapril y citalopram se realiza exámenes de control, entre los que destacan sodio plasmático de 127 mEq/L, potasio plasmático de 4,1 mEq/L, creatinina plasmática de 0,9 mg/dl y sodio urinario de 60 mEq/L. ¿Cuál es la causa más probable de su hiponatremia?

A) Uso del enalapril
B) Reacción secundaria al citalopram
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Hipotiroidismo descompensado

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Reacción secundaria al citalopram** (opción **B**). Tiene un probable SSIADH (hiponatremia, con sodio urinario alto). El citalopram puede causarlo.. Tratamiento: levotiroxina 1,6 µg/kg. Ajustar por TSH hasta rango 0,4-4 mU/L. Control cada 6 semanas. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 164 1.09.1.010 · Hiponatremia crónica asint

Paciente mujer joven sodio bajo osmolaridad sanguínea baja, sodio urinario sobre 100, osmolaridad urinaria 520 (VN 50-1200), VEC normal a. SIADH b. Uso de diuréticos (creo que era esta, pues el SIADH debería tener osmolaridad urinaria alta, que alguien confirme pls)

C) Insuficiencia suprarrenal
D) Hipotiroidismo
C) Ninguna de las anteriores es correcta
D) Todas las anteriores son correctas
E) No se dispone de información suficiente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Insuficiencia suprarrenal, Hipotiroidismo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 50 1.09.3.009 · Terapia diurética

Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con enalapril, amllodipino, furosemida y carvedilol. Realiza un cambio de diurético por clartadilona, con buena respuesta clínica, reduciendo de la disnea. Sin embargo evolucionando con debilidad de las extremidades inferiores, por lo que se solicitan exámenes que muestran creatinina plasmática: 1,0 mg/dl y electrolitos plasmáticos, que resultan Na+:132 mEq/L y K+: 3,5 mEq/L. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Aumentar el consumo de agua
B) Restringir el consumo de cloruro de sodio
C) Suspender la clortadinona
D) Bajar la dosis de enalapril
E) Iniciar hidroclorotiazida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy difícil, pero su clínica es de hipokalemia y el K está en el límite bajo. El consumo excesivo de sal, mezclado con el uso de tiazidas (como la clortalidona) producen hipokalemia.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 60 1.09.3.009 · Terapia diurética

Un paciente de 78 años, diabético, hipertenso y dislipidémico está en tratamiento con metformina, glibenclamida, enalapril, hidroclorotiazida, aspirina y atorvastatina. Se realiza exámenes de laboratorio, entre los que destacan sodio plasmático: 130 mEq/L, potasio plasmático: 3,4 mEq/L, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?

A) Nefroesclerosis hipertensiva
B) Uso de hidroclorotiazida
C) Nefropatía diabética
D) Uso de enalapril
E) Uso de aspirina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto la hiponatremia como la hipokalemia se explican por la HCTZ (también por otras tiazidas, como la clortalidona; e incluso por los diuréticos de asa, como la furosemida).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 34 1.09.2.010 · Insuficiencia renal aguda

Un paciente de 76 años consulta por dolor lumbar derecho intenso, EVA; 9/10, de 6 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psicomotora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiempos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes se aprecian 100 glóbulos rojos por campo y 20 glóbulos blancos por campo, en el sedimento de orina. Destaca, además, electrocardiograma con fibrilación auricular y creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Quiste renal complicado
B) Urolitiasis
C) Pielonefritis aguda
D) Obstrucción ureteral por coágulos
E) Embolia renal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una embolia renal clásica, en contexto de una FA (ritmo irregular). Si no tuviera la FA podría haber sido un cólico renal.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 18 1.09.2.010 · Insuficiencia renal aguda

Un paciente de 66 años consulta por dolor lumbar derecho de 8 horas de evolución, irradiado al flanco ipsilateral y asociado a fiebre, vómitos, hematuria y agitación psico- motora. Al examen físico presenta FC: 100x', con ritmo cardíaco irregular, en dos tiem- pos, PA: 120/70 mmHg y puñopercusión positiva a derecha. En sus exámenes, se apre- cian incontables glóbulos rojos en el sedimento de orina y 20 glóbulos blancos por cam- po. Destaca además creatinina plasmática de 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Aneurisma aórtico abdominal roto
B) Urolitiasis
C) Pielonefritis aguda
D) Torsión testicular
E) Embolia renal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una embolia renal clásica. El ritmo irregular, hace pensar en FA, como causa de la embolia. El resto del cuadro clínico y de los exámenes, son característicos.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 1 1.09.1.009 · Hipertensión arterial secu

Un paciente de 18 años consulta por cefalea de algunas semanas de evolución, que ha ido en aumento, hasta alcanzar gran intensidad. En su examen físico destaca presión arterial 170/100 mmHg, FC: 72x' y presencia de un soplo abdominal, en el flanco derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Disección aórtica
B) Aneurisma aórtico abdominal
C) Hipertensión esencial
D) Hipertensión renovascular
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una HTA renovascular clásica, tanto por el soplo renal, como por la clínica de hipertensión secundaria (joven, severa),

---

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 24 1.09.1.009 · Hipertensión arterial secu

Un paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, diagnosticada hace un año en tratamiento con atenolol 50 mg cada 12 horas y enalapril 20 mg cada 12 horas, refiere múltiples tomas de presión arterial con valores sobre 160/100 mmHg. Al examen físico tiene FC: 60x', PA: 158/100 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 143 mEq/L, potasio: 3,4 mEq/L, hemograma normal y TSH: 3,2 UI/L. ¿Con qué examen se debe proseguir su estudio?

A) Cortisol basal y post dexametasona
B) Monitoreo de presión arterial de 24 horas
C) Calcemia y niveles de paratohormona
D) Metanefrinas y normetanefrinas en orina
E) Ecografía Doppler de arterias renales

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ecografía Doppler de arterias renales** (opción **E**). Todos los antihipertensivos tienen eficacia similar; la elección depende de comorbilidades y efectos adversos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 83 1.09.1.009 · Hipertensión arterial secu

Paciente con HTA de difícil control, creatinina levemente elevada e hiperkalemia. ¿Cuál es el estudio a solicitar?

A) Ecografía Doppler de arterias renales
B) Renograma isotópico con captopril
C) Arteriografía renal selectiva
D) AngioTAC renal
E) Biopsia renal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ecografía Doppler de arterias renales). Ecografía Doppler de arterias renales. Clase sobre diagnóstico, objetivos y pilares del tratamiento de la hipertensión arterial. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 113 1.09.1.006 · Glomerulopatía lúpica

Una paciente de 26 años, consulta por malestar general, asociada a cefalea y orinas oscuras. Refiere fotosensibilidad. Al examen físico tiene FC: 66x'. PA: 160/106 mmHg, úlceras orales y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con eritrocitos abundantes, con 17% de dismorfia, proteinuria 500 mg/L. Su creatinina plasmática resulta 1,4 mg/dl y la fracción del complemento C3 está disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nefropatía lúpica
B) Nefropatía por IgA
C) Vasculitis ANCA positivo
D) Glomerulonefritis postestreptocócica
E) Glomerulopatía por cambios mínimos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Nefropatía lúpica** (opción **A**). Es un lupus sistémico clásico, con afectación renal.. El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por expectación ansiosa constante sobre múltiples eventos o situaciones, con miedo generalizado a que algo malo ocurra, ya sea a la propia persona, a sus seres queridos o en el entorno. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 70 **1.09.1.016 · Pielonefritis aguda no com**

Mujer con hipoacusia neuro con ITU febril → PNA . Qué ATB dejar: a. Meropenem

B) Gentamicina

C) Amikacina d. Nitrofurantoína —> aminoglucosidos estarían contraindicados en hipoacusia neurosensorial o no?? si pq son ototoxicos

C) Staphylococcus aureus

D) Streptococcus pneumoniae

E) Escherichia coli

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Amikacina d. Nitrofurantoína —> aminoglucosidos estarían contraindicados en hipoacusia neurosensorial o no?? si pq son ototoxicos). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 138 **1.09.1.016 · Pielonefritis aguda no com**

Una paciente de 82 años presenta un cuadro de fiebre alta, disuria dolorosa y orinas turbias, más hematuria macroscópica. Al examen físico, tiene PA: 120/80, FC: 90x', T°: 38,9°C. Se solicitan exámenes, entre las que destaca hemograma con 20.000 glóbulos blancos por mm3, PCR: 12 mg/L. El sedimento orina muestra más de 50 glóbulos blancos por campo, con bacterias abundantes y el urocultivo está pendiente. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección?

A) Gentamicina

B) Amikacina

C) Moxifloxacino

D) Ceftazidima

E) Cefotaximo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien no tiene indicación evidente de hospitalización, a pesar de ser una pielonrfritis aguda, de las opciones, la más acertada parecía ser el cefotaximo, que cubre muy bien a los gram negativos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 140 **1.09.1.015 · Osteodistrofia en insufici**

Un paciente de 64 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica, con clearence de 40 ml/min se realiza exámenes de control que muestran fósforo: 4,0 mg/dl, calcio: 8,5, PTH: 120 pg/ml (VN: menor a 55) y TSH: 4,0 UI/L. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Niveles plasmáticos de 25-OH-vitamina D

B) Niveles de T4 libre

C) Calciuria de 24 horas

D) Magnesemia

E) Bicarbonato plasmático

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal. Si bien la calciuria de 24 horas permite ver el grado de pérdida de calcio diario, lo más importante será determinar los niveles de vitamina D, ya que tanto la falla renal, como el hiperparatiroidismo mismo disminuyen sus niveles, agravando la osteodistrofia. Al medirla, se puede observar el déficit, de modo de indicar suplementos de vitamina D y, además, permite descartar el déficit primario de vitamina D, como causa del HPP.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 56 **1.09.1.020 · Edema generalizado (anasar**

Un paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, sin tratamiento, consulta por edema de las extremidades inferiores y malestar. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 70x', edema marcado en ambas extremidades inferiores, con signo de la fóvea, hígado palpable, examen cardíaco normal y murmullo pulmonar presente, con escasos crépitos basales. En sus exámenes destaca creatinina: 2,2 mg/dl, 5 mg/dl, Na+: 136 mEq/l, K+: 5,3 mEq/l y Cl-: 95 mEq/l. ¿Qué diurético es de elección para el manejo del edema en este paciente?

A) Clortalidona

B) Hidroclorotiazida

C) Furosemida

D) Indapamida

E) Espironolactona

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Prefunta difícil. Tiene un edema por IRC (crea de 2,2) y también por IRC, por lo que la furosemida debería servir. Además, la A, B y D son tiazidas (la indapamida no es una tiazida propiamente tal, pero es cercana), por lo que ninguna es. La E sirve para aumentar la sobrevida en la ICC, pero junto a Enalapril y betabloqueo y en esta pregunta se interroga directamente por el manejo del edema.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 6 **1.09.1.001 · Acidosis e hiperkalemia en**

Un paciente de 66 años con antecedente de insuficiencia renal crónica, en etapa IIIB, con creatinina estable en 1,8 mg/dl y clearence de creatinina estimado de 35 ml/min. Se realiza exámenes de laboratorio que muestran sodio: 138 mEq/L, cloro: 102 mEq/L potasio: 4,8 mEq/L, bicarbonato plasmático: 16 mEq/L y anion gap: 10. ¿Cuál es la causa más probable de sus alteraciones?

A) Acumulación de ácidos orgánicos

B) Disminución de la producción de bicarbonato

C) Cetosis

D) Acumulación de ácido úrico

E) Intoxicación por medicamentos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Acidosis metabólica con anión gap normal: El diagnóstico es acidosis metabólica, ya que el bicarbonato está bajo con un anión gap normal (entre 8 y 12). El anion gap se eleva en las demás opciones, ya que refleja la acumulación de ácidos orgánicos. En este caso, la causa es la misma falla renal.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 150 1.09.1.001 · Acidosis e hiperkalemia en

Un paciente de 82 años, diabético e hipertenso, consulta por malestar general y edema de extremidades inferiores. Al examen físico tiene PA: 150/100 mmHg, FC: 63x', edema blando bimaleolar +++. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 86 mg/dl, K+: 5,8 mEq/L, Na+: 133 mEq/L, bicarbonato: 15 mmol/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Hemodiálisis
B) Gluconato de calcio
C) Peritoneodiálisis
D) Bicarbonato de sodio
E) Amlodipino

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una arritmia maligna, pero, por lo general, el gluconato de calcio solo está indicado si hay compromiso electrocardiográfico o si el potasio está sobre 7 mEq/L. La acidosis sí se debe tratar con bicarbonato de sodio, ya sea EV o VO, dependiendo del pH (en este caso no lo dan, pero por el nivel de bicarbonato parece candidato a EV). Las diálisis solo se indican si es que tiene un síndrome urémico o una complicación grave y refractaria al tratamiento médico. Como se pregunta la conduta inicial, en conjunto con varios especialistas, asumimos que la respuesta es el gluconato de calcio, para el manejo de la hiperkalemia, pero insistimos en que es una pregunta mala.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 140 1.09.2.006 · Hipokalemia

Un paciente de 56 años, hipertenso, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida presenta irregularidad en sus presiones arteriales, por lo que se decide reemplazar el diurético por clortalidona, con buena respuesta. Se solicitan exámenes de control, entre los que destacan creatinina: 1,0 mg/dl, potasemia: 3,3 mEq/L y natremia: 140 mEq/L. La conducta más adecuada es:

A) Reemplazar el enalapril por losartán
B) Disminuir cloruro de sodio
C) Reemplazar la clortalidona por furosemida
D) Administrar suero fisiológico
E) Disminuir la dosis de enalapril

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Disminuir cloruro de sodio** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 125 1.09.1.007 · Hipernatremia, poliuria

Paciente usuaria de lamotrigina, ácido valproico y litio, presenta diuresis de 12.600 mL/día, deshidratación e hipernatremia. ¿Cuál es la causa más probable?

A) Ácido valproico
B) Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)
C) Lamotrigina
D) Polidipsia psicogénica inducida por antipsicóticos
E) Hiperglicemia osmótica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica)). Carbonato de litio (diabetes insípida nefrogénica). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 94 1.09.1.007 · Hipernatremia, poliuria

Un paciente de 25 años, con antecedente de trastorno bipolar de difícil manejo, en tratamiento con lamotrigina, litio, diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de poliuria de cerca de 12 litros diarios, asociado a alta ingesta de aguda. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, sodio: 154 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L, glicemia de ayunas: 80 mg/dl y hemograma normal. ¿Cuál de las siguientes opciones explica sus alteraciones?

A) Polidipsia psicógena
B) Consumo de lamotrigina
C) Consumo de litio
D) Consumo de clorpromazina
E) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 107 1.09.2.005 · Hiperkalemia grave

Paciente con bradicardia de 30 lpm e hiperkalemia de 8,3 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Bicarbonato de sodio endovenoso
B) Insulina + glucosa endovenosa
C) Gluconato de calcio endovenoso
D) Kayexalate oral
E) Hemodiálisis de urgencia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Gluconato de calcio endovenoso** (opción **C**). Gluconato de calcio endovenoso. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 104 1.09.2.005 · Hiperkalemia grave

Una paciente de 73 años, diabética e hipertensa, con insuficiencia renal crónica, en tratamiento con insulina NPH, losartán, amlodipino y atenolol, presenta malestar general, seguido de síncopes en varias oportunidades en día de hoy, por lo que es llevada a la urgencia. Al examen físico tiene FC: 30x', PA: 70/36 mmHg, sopor profundo, sudoración, ausencia de signos focales. Se solicitan exámenes de laboratorio entre los que destaca Na+: 130 mEq/L, K+: 8,2 mEq/L, Cl-: 98 mEq/L, pH: 7,29, HCO3-: 18 mEq/L, glicemia capilar: 180 mg/dl. El resto de la analítica está pendiente. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Instalar marcapasos externo transitorio
B) Administrar gluconato de calcio endovenoso
C) Administrar atropina
D) Hemodiálisis de urgencia
E) Administrar suero fisiológico endovenosos

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Administrar suero fisiológico endovenosos** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 159 1.09.2.005 · Hiperkalemia grave

Paciente presenta bradicardia de hasta 35, Hipotensa, K 8, Cual es la primera medida a. Gluconato de Ca → Una paciente con bradicardia y potasio como 7-8 (creo que esta había salido antes en algun EUNACOM) b. Diálisis de urgencia

C) MCP transitorio (POR QUE ESTA NO ES SI TIENE UN BLOQUEO AV SI EN EL MARCAPASO SE VA A MORIR, porque lo primero en toda hiperK y arritmia es estabilizar membrana con Gluconato Ca)
B) Insuficiencia cardíaca
C) Fibrilación auricular
D) Infarto agudo al miocardio
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (MCP transitorio (POR QUE ESTA NO ES SI TIENE , Insuficiencia cardíaca) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 151 1.09.2.005 · Hiperkalemia grave

Un paciente de 27 años, con antecedente de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, no asiste a su sesión dialí8ca del día sábado, debido a que acude a una fiesta con abundante consumo de comida y bebidas. El día lunes amanece con marcado malestar general y dificultad para mover las extremidades, por lo que es llevado al servicio de urgencia. Al examen Fsico se constata tetraparesia y frecuencia cardíaca de 40 la8dos por minuto. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de Guillain-Barré
B) Hipokalemia
C) Hiperkalemia
D) Hipocalcemia
E) Hiperfosfatemia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La falla renal Gende a la hiperkalemia y su clínica consiste precisamente en debilidad muscular y arritmias cardíacas de diversa índole, desde bloqueos hasta taquicardias ventriculares. El primer examen a realizar no son los electrolitos plasmáticos (sí se piden), sino el electrocardiograma, que es inmediato, ve las ondas T altas o “picudas” y permite un tratamiento inmediato con gluconato de calcio endovenoso, para evitar arritmias. Luego, se trata con insulina más glucosa (la insulina mete el potasio a las células y la glucosa evita las hipoglicemias), salbutamol y resinas de intercambio (ej. sulfonato de poliestireno).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 92 1.09.2.007 · Hiponatremia aguda grave

Un paciente de 72 años, fumador de 40 paquetes/año, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas sin tratamiento actual, presenta un cuadro de 7 días de evolución de cefalea y tendencia a la desorientación. En sus exámenes destaca una concentración sérica de sodio de 121 mEq/L, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) SIADH (Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética)
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome carcinoide
D) Accidente vascular encefálico
E) Hipercalcemia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome de Secreción Inapropiada de Hormona Antidiurética (SIADH): El caso describe un SIADH clásico con hiponatremia severa y compromiso neurológico. La causa en este caso es el cáncer de pulmón, ya que las alteraciones del sistema nervioso central y las alteraciones pulmonares son las causas más frecuentes de SIADH. Por el compromiso neurológico, se debe tratar con suero hipertónico a pasar muy lento, para evitar la mielinolisis pontina. Si hubiese estado bien, se maneja solo con restricción de agua libre.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 41 1.09.2.007 · Hiponatremia aguda grave

Hombre 60 años con inicio hace 3 semanas de carbamazepina, comienza con náuseas, malestar gástrico, confusión hace 2 días, alteración electrolítica:

A) Hiponatremia
B) HIPOCALCEMIA???. Era hiponatremia inducida por carbamazepina. - además la clínica (compromiso SNC) orientaba a disnatremia, no tenía nada de discalcemia/diskalemia.
C) Hipokalemia
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Hiponatremia). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (HIPOCALCEMIA???. Era hiponatremia inducida po, Hipokalemia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 103 1.09.3.011 · Trasplante renal, indicaci

Px trasplante renal hace 9 años, usuario de tacrolimus, hace una semana de compromiso del estai.do general, dolor en zona injerto. Exs de rutina hace 10 días muestran niveles plasmaticos de tacrolimus >5 (estaba en rango normal), crea en 0.9. Exs actuales: crea 2.3, orina completa leucocitos y bacterias. ¿Diagnóstico? Alternativas:

A) Rechazo agudo
B) rechazo crónico
C) intoxicación por tacrolimus
D) pielonefritis del injerto
E) pielonefritis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **pielonefritis del injerto** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 8 1.09.2.011 · Pielonefritis aguda compli

Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, consulta por cuadro de fiebre, malestar general, náuseas, disuria dolorosa y dolor lumbar derecho. Al examen físico, tiene fiebre de 38,9°C, frecuencia cardíaca 95x', presenta puño percusión positiva a derecha. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 50 leucocitos por campo y abundantes bacterias, estando pendiente el resultado del urocultivo. Las pruebas de bienestar fetal no muestran alteraciones. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para su manejo?

A) Ciprofloxacino
B) Nitrofurantoína
C) Amoxicilina más ácido clavulánico
D) Ceftriaxona
E) Ampicilina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pielonefritis aguda en el embarazo: El cuadro clínico y el sedimento de orina sugieren pielonefritis aguda. Durante el embarazo, las pielonefritis requieren hospitalización y tratamiento con antibióticos intravenosos, generalmente cefalosporinas. Se recomienda la tercera generación (ceftriaxona), aunque también se pueden usar de primera generación. El ciprofloxacino está contraindicado en el embarazo. La nitrofurantoína solo es efectiva para infecciones urinarias bajas. La amoxicilina/ácido clavulánico y la ampicilina no se recomiendan en el tratamiento de infecciones urinarias.

DIABETES MELLITUS & NUTRICIÓN

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 06

73 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

22 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.02.1.002	Diabetes gestacional	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.003	Diabetes mellitus pregestacional	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.004	Diabetes Mellitus tipo 1	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.005	Diabetes mellitus tipo 2	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	16 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.006	Diabetes por corticoides	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.007	Dislipidemias	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	6 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.009	Insuficiencia renal y diabetes	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.012	Obesidad	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.014	Pié diabético y otras infecciones en diabetes	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.015	Retinopatía diabética	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.016	Síndrome metabólico	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.1.017	Síndromes carenciales de vitaminas y minerales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.2.002	Cetoacidosis	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 06 · C.31 (Pág. 66)
1.02.2.003	Coma hiperosmolar	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.2.004	Déficit agudo de tiamina	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.2.005	Hipertrigliceridemia grave	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.2.006	Hipoglicemias	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.3.002	Anorexia nerviosa	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.3.006	Prevención de Diabetes Mellitus tipo 2	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.4.015	Glicemia capilar	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.02.4.017	Hemoglobina glicosilada	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)
1.02.4.024	Test de tolerancia a la glucosa	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 06 · Diabetes Mellitus (Pág. 8)

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 17 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un hombre de 33 años, obeso, consulta por polidipsia y baja de peso de 6 kilogramos, en los últimos dos meses. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes, entre los que destacan glicemia de ayuno de 245 mg/dl y hemoglobina glicosilada: 9,2%. El tratamiento inicial más adecuado es:

A) Metformina
B) Sitagliptina
C) Insulina
D) Liraglutide
E) Glibenclamida

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por los síntomas de diabetes (baja de peso y polidipsia), como por la HbA1c mayor a 9%, está indicada la insulina.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 107 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 72 años, con antecedente de un infarto miocárdico, hace 2 meses. Durante la hospitalización, se diagnosticó diabetes mellitus, iniciándose metformina 850 mg cada 12 horas. Sin embargo, desde entonces ha presentado diarrea. Sus glicemias de ayuno son cercanas a 140 mg/dl y su hemoglobina glicosilada resulta 8,2%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reemplazar la metformina por glibenclamida
B) Agregar insulina NPH
C) Reemplazar el tratamiento por metformina 750 mg XR
D) Reemplazar la metformina por sitagliptina
E) Aumentar la dosis de metformina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene efectos adversos, por lo que se debe suspender la metformina y cambiar a sitagliptina (por lo frágil: adulto mayor con infarto reciente, se prefiere la sitagliptina sobre la glibenclamida). No tenía indicaciones evidentes de insulina.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 105 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 59 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850mg dos veces al día y glibenclamida 5mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender la glibenclamida
B) Aumentar dosis de glibenclamida
C) Suspender metformina
D) Aumentar dosis de metformina
E) Mantener el tratamiento sin cambios

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si la hemoglobina glicosilada está bajo 7%, no es necesario hacer cambios en el tratamiento hipoglicemiante, aunque no sea el óptimo.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 132 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 45 años se realiza glicemias de ayuno que resultan 128 y 136 mg/dl. Se solicita hemoglobina glicosilada, que resulta 7,2%. ¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?

A) Glibenclamida
B) Metformina
C) Pioglitazona
D) Sitagliptina
E) Repaglinida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene diagnóstico de diabetes (dos glicemias mayores o iguales a 126). Por la edad y por no tener mayores antecedentes, lo más probable es que sea tipo 2. Por no tener indicaciones de insulina (ej. HbA1c mayor a 9%), se debe iniciar con metformina.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 24 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 81 años, con antecedente de diabetes, en tratamiento con metformina 850 al día, se realiza exámenes de control, entre los que destaca una hemoglobina A1c de 7,5%. La conducta más adecuada es:

A) Mantener el tratamiento
B) Agregar glibenclamida
C) Subir la dosis de metformina
D) Agregar insulina
E) Agregar sitagliptina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener el tratamiento** (opción **A**). Recordar que en el mayor de 75 años el objetivo de la HbA1c es menor a 8%. Por tanto, está bien.. Objetivo general de HbA1c <7%. En adultos mayores frágiles, <8%. En jóvenes sin comorbilidades, <6.5%. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 162 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 45 años, presenta polidipsia y poliuria de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 4 kilogramos en un mes. Al examen físico, se observa obeso con IMC: 35 y con presencia de acantosis nigricans en el cuello, sin otras alteraciones. Se solicita glicemia de ayuno, que resulta 318 mg/dl.

A) Iniciar dieta y metformina
B) Iniciar dieta y controlar
C) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
D) Repetir la glicemia de ayuno
E) Iniciar insulina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Iniciar dieta y metformina). El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se basa en un enfoque escalonado que comienza siempre con cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio) más metformina como fármaco de primera línea. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 33 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 17 años, obeso, se realiza chequeo con glicemia de ayuno que resulta en 130, por lo que se repite este examen obteniendo 137, no ha presentado síntomas. En el examen físico destaca presencia de acantosis nígricans en pliegue cervical y acrocordones. El diagnóstico más probable es:

A) Diabetes mellitus tipo 1
B) Diabetes mellitus tipo 2
C) Diabetes mellitus autoinmune
D) Intolerancia a la glucosa
E) Glicemia de ayuno alterada

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien es un adolescente, la presencia de acantosis nigricans es muy sugerente de RI y por tanto de DM2. La obesidad también orienta a DM2, pero recordar que no basta, ya que un niño obeso con diabetes probablemente es tipo 1. Además al no estar tan altas las glicemias hace pensar más en DM2, porque la DM1 suelen debutar bastante descompensados.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 125 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 55 años, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2000mg al día, glibenclamida 15mg al día y enalapril 20mg al día, acude a control con exámenes, donde destaca glicemia de ayuno de 180mg/dL y hemoglobina glicosilada de 8,8%. Se ha mantenido sin síntomas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Aumentar dosis de glibenclamida
B) Aumentar dosis de metformina
C) Iniciar insulina
D) Reemplazar metformina con rosiglitazona
E) Reemplazar glibenclamida con sitagliptina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy capciosa: Aún se puede elevar algo la GBC (a 20) y la MTF (a 3.000), pero probablemente tendrá poco efecto, para lo mal controlado que está. Su HbA1c es 8,8%, por lo que es poco probable que baje a 7%, con esas medidas. No estoy 100% seguro de esta respuesta, pero yo marcaría insulina sin dudarlo mucho.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 151 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Diabético en tratamiento con metformina, Hb1Ac >9%. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Agregar glibenclamida 5 mg/día
B) Agregar sitagliptina 100 mg/día
C) Agregar liraglutida 1,2 mg SC
D) Aumentar metformina al máximo
E) Insulina NPH

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Insulina NPH** (opción **E**). Insulina NPH. Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 118 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 85 años, con antecedente de deterioro funcional y cognitivo inicial y diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg dos veces al día y glibenclamida 5 mg cada 12 horas, se realiza exámenes de control entre los que destaca una creatinina de 1,0 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 6,9%. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender la glibenclamida
B) Disminuir la dosis de glibenclamida a 5 mg una vez al día
C) Suspender metformina
D) Disminuir dosis de metformina
E) Mantener el tratamiento sin cambios

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Suspender la glibenclamida** (opción **A**). La glicemia de las 3 am está determinada por la insulina nocturna, cuyo peak de acción es a las 5. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se basa en un enfoque escalonado que comienza siempre con cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio) más metformina como fármaco de primera línea. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 149 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente de 82 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y dieta, acude a control, con glicemia de ayuno de 355 mg/dl, hemoglobina glicosilada de 9,5%. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su diabetes?

A) Agregar glibenclamida
B) Agregar sitagliptina
C) Inicial insulina NPH
D) Iniciar insulina glargina
E) Iniciar liraglutide

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Inicial insulina NPH** (opción **C**). Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 150 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Paciente con polidipsia, poliuria, baja de peso y glicemia >300 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Metformina 850 mg cada 12 horas
B) Iniciar insulina
C) Empagliflozina 10 mg/día
D) Liraglutida 0,6 mg subcutáneo
E) Sitagliptina 100 mg/día

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar insulina** (opción **B**). Iniciar insulina. Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 161 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Paciente de 65 años con DM2 en tratamiento con insulina NPH nocturna. Presenta hiperglicemias en ayuno de 200-240 mg/dL. Glicemias a las 3 AM: 65 mg/dL. ¿Cuál es el ajuste más adecuado?

A) Agregar glibenclamida
B) Agregar sitagliptina
C) Agregar pioglitazona
D) Reducir dosis de insulina NPH nocturna
E) Cambiar a insulina basada en metformina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fenómeno de Somogyi: hipoglicemia nocturna (3 AM) → hiperglicemia de rebote en ayuno. La glicemia de 65 mg/dL a las 3 AM confirma hipoglicemia nocturna. La solución es REDUCIR la insulina NPH, no aumentarla. Confirmar midiendo glicemia a las 3 AM.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 141 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente con antecedente de una angioplastia coronaria hace 6 meses, diabético e hipertenso, en tratamiento con metformina 2 gramos al día, presenta HbA1c de 8,2% y glicemia de ayuno de 180 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento más adecuada?

A) Agregar glibenclamida
B) Iniciar empaglifozina
C) Iniciar saxagliptina
D) Agregar insulina NPH nocturna
E) Iniciar pioglitazona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta ultra específica, pero si alguien tiene máximo riesgo cardiovascular, por enfermedad coronaria (además de la diabetes), los hipoglicemiantes de elección para agregarle a la metformina son la empaglifozina y el liraglutide, es decir, los análogos de las incretinas. Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 94 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Un paciente 67 años, diabético en tratamiento con metformina 1,5 gramos al día, consulta por edema de extremidades inferiores asociado a orinas espumosas. Al exa- men físico se constata edema blando de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes entre los que destaca una glicemia de ayuno de 215mg/dL, hemoglobina glicosilada de 12,5%, creatininemia 1,2mg/dL, proteinuria +++ y albuminemia 3,0g/dL. La conducta

A) Aumentar dosis de metformina
B) Iniciar insulina NPH
C) Reemplezar la metformina por glimepiride
D) Agregar glibenclamida al tratamiento
E) Reemplazar la metformina por insulina cristalina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar insulina NPH** (opción **B**). Tanto el síndrome nefrótico, como especialmente la HbA1c mayor a 9%, obligan a iniciar insulina.. Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 114 1.02.1.005 · Diabetes mellitus tipo 2

Pregunta 114 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 32 años, normopeso, diagnosticado de diabetes desde los 20 años, en tratamiento. Su padre, su hermano y su abuelo son diabéticos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) DM tipo 1
B) DM tipo 2
C) DM LADA
D) DM Mody
E) DM mitocondrial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La diabetes Mody se caracteriza por ser genética, produciendo resistencia a la insulina. Suele tener buen pronóstico. Las patologías mitocondriales se heredan por la madre a todos los hijos. La diabetes LADA por ser autoinmune no se repite tantas tan seguido en la familia, aunque sí hay un mayor riesgo.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 17 1.02.1.004 · Diabetes Mellitus tipo 1

Un paciente de 12 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de NPH matinal, despierta con glicemias de ayuno muy elevadas, asociadas a hipoglicemias frecuentes antes del almuerzo. Su hemoglobina glicosilada es de 11,7%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reemplazar el tratamiento por insulina glargina en la mañana
B) Dejar dos dosis de insulina NPH más tres refuerzos de insulina cristalina precomidas
C) Agregar insulina NPH nocturna
D) Reemplazar la insulina NPH matinal por insulina NPH nocturna
E) Agregar metformina al tratamiento

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La DM1 se debe tratar con esquema intensificado: idealmente insulina glargina basal, con refuerzos con insulina ultrarrápida. Se acepta también las dos dosis de NPH, con referzos con IC precomidas. Las demás opciones son claramente insuficientes.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 113 1.02.1.004 · Diabetes Mellitus tipo 1

Una paciente de 36 años, hipotiroidea y con antecedente de vitíligo fue diagnosticada de diabetes hace un año. Está en tratamiento con 2 gramos de metforminal al día y 20 mg de glibenclamida al día, más dieta. Su hemoglobina glicosilada es de 8,5% y su glicemia de ayuno resulta 196 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Diabetes mellitus 1 - LADA
B) Diabetes mellitus Mody
C) Diabetes mellitus secundaria
D) Diabetes mellitus 2 con tendencia a la cetosis
E) Diabetes mellitus controlada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por los antecedentes de autoinmunidad, como por el mal control metabólico con altas dosis de HGO, se trata de una diabetes LADA (autoinmune del adulto). Además, tiene un síndrome poliglandular (reacción autoinmune contra múltiples glándulas).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 34 1.02.1.004 · Diabetes Mellitus tipo 1

Una paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo desde la adolescencia, vitíligo y diabetes diagnosticada hace un año, en tratamiento con régimen oral, acude a control con glicemia de ayuno en 250 mg/dL y hemoglobina glicosilada en 9,0%. El diagnóstico más probable es:

A) Diabetes mellitus tipo 1
B) Diabetes mellitus tipo 2
C) Diabetes mellitus autoinmune
D) Hipopituitarismo autoinmune
E) Neoplasia endocrina múltiple tipo 1

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El diagnóstico es una diabetes LADA, que si bien es igual a la DM1, tiene un nombre distinto. Orientan el vitíligo, el hipotiroidismo (autoinmunes ambos) y la falta de respuesta.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 16 1.02.1.004 · Diabetes Mellitus tipo 1

Una paciente de 50 años, con diagnóstico de artritis reumatoide, en tratamiento con prednisona 15 mg/día, presenta glicemia de ayuno de 115, y glicemias prealmuerzo y precena de 230 y 295 mg/dl respectivamente. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esta paciente?

A) Dieta y ejercicio
B) Metformina
C) Glibenclamida
D) Pioglitazona
E) Insulina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Probable diabetes LADA por el antecedente de AR y por la severidad. Se trata con insulina, igual a DM1. No parece una DM por corticoides.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 37 1.02.1.009 · Insuficiencia renal y diab

Una paciente de 67 años, monorrena, es diagnos8cada recientemente de diabetes mellitus 8po 2. Sus exámenes muestran HbA1c de 8,5%, glicemia de ayuno de 132 mg/dL, crea8nina de 4,1 mg/dL, nitrógeno ureico de 68 mg/dL, potasio plasmá8co de 4,2 mEq/L y un clearance de crea8nina es8mado de 12 mL/min. Presenta una relación albuminuria/crea8nuria de 1.100 mg/g. ¿Qué fármaco es el más adecuado para iniciar el tratamiento?

A) Meeormina
B) Glibenclamida
C) Vildaglip2na
D) Dapagliflozina
E) Semaglu2da

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por tener HbA1c mayor a 7%, se debe avanzar en el tratamiento. Además, por la IRC están contraindicados la mayoría de los hipoglicemiantes orales, siendo indicación de insulina. Como alternativa modera están los agonistas GLP-1, como la semagluGda, liragluGda y dulagluGda. Los inhibidores SGLT-2, como la empaglifozina y la dapaglifozina, en cambio, requieren de una función renal adecuada para funcionar, ya que justamente bajan los niveles de azúcar, mediante glucosuria. Ambos, GLP- 1 y SGLT-2 son úGles en riesgo cardiovascular elevado, siendo una alternativa a la insulina.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 18 1.02.1.009 · Insuficiencia renal y diab

Un paciente de 60 años, diabético tipo 2, en tratamiento con 500 mg de metformina al día, acude a control, con hemoglobina glicosilada de 8,8%, proteinuria (+) y claerence de creatinina de 50 ml/min. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Subir la dosis de metformina
B) Agregar glibenclamida
C) Agregar insulina NPH nocturna
D) Tratar con mezcla de insulinas
E) Agregar glipizida al tratamiento

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La insuficiencia renal contraindica los hipoglicemiantes orales: se debe dejar insulina. El tratamiento que tenía era pésimo.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 122 1.02.1.009 · Insuficiencia renal y diab

Un paciente de 78 años, diabé8co 8po 2 e hipertenso, sin controles hace 5 años, en tratamiento con enalapril, hidrocloro8azida, amlodipino y me{ormina, Acude a control, con exámenes de laboratorio. Su presión arterial es de 152/96 mmHg y su frecuencia cardíaca de 68 la8dos por minuto. Su examen cardiopulmonar y abdominal es normal. Entre sus exámenes destaca hemoglobina glicosilada: 6%, crea8nina plasmá8ca: 3,8 mg/dL, natremia: 140 mEq/L y potasemia: 4,8 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener el tratamiento
B) Suspender la meeormina
C) Suspender el diuré2co
D) Suspender el enalapril
E) Suspender el amlodipino

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hay dos formas de enfrentar esta pregunta. 1. Paciente mayor de 75 años, el objetivo de hemoglobina glicosilada es menor a 8%, por tanto, está sobretratado y se puede suspender la me~ormina. 2. Tiene una insuficiencia renal crónica avanzada (creaGnina 3,8 mg/dl equivale a un clearence bajo 15 ml/min), por lo que está contraindicada la me~ormina. Los demás fármacos se pueden mantener, especialmente tomando en cuenta que su presión arterial sigue elevada (objetivo en mayores de 75 años suele ser <140-150/90 mmHg, en la mayoría de las fuentes) y que los electrolitos están normales.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 78 1.02.1.009 · Insuficiencia renal y diab

Un paciente de 45 años, diagnosticado de diabetes hace un mes, se le indicó tratamiento con metformina, la cual suspendió por que le producía diarrea, desde entonces ha estado asintomático. Acude a control con exámenes donde destaca hemoglobina glicosilada de 8,5%, glicemia de ayuno 180mg/dL, creatinina de 1,5 mg/dL. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Indicar Insulina
B) Indicar glibenclamida
C) Indicar rosiglitazona
D) Indicar acarbosa
E) Indicar metformina de acción prolongada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Indicar Insulina** (opción **A**). Por la crea de 1,5. Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 152 1.02.1.007 · Dislipidemias

Diabético con HbA1c en buen rango, LDL 135 mg/dL y TG 330 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Fenofibrato
B) Gemfibrozilo
C) Atorvastatina
D) Omega-3 en dosis farmacológica
E) Ezetimibe

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Atorvastatina** (opción **C**). Atorvastatina. El LDL es el principal objetivo terapéutico en dislipidemias De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 134 1.02.1.007 · Dislipidemias

Un paciente de 35 años, en tratamiento con atorvastatina, por hipercolesterolemia y cuyo padre tuvo un infarto a los 40 años, presentó mialgias y artralgias, por lo que decidió suspender el medicamento, sin indicación médica. Se controla con exámenes, entre los que destaca colesterol total: 354 mg/dl, colesterol LDL: 244 mg/dl, colesterol HDL: 70 mg/dl, triglicéridos: 198 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 254 UI/L. El tratamiento más adecuado es:

A) Colestiramina
B) Dieta estricta
C) Rosuvastatina
D) Ezetimibe
E) Fenofibrato

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien tiene todos los lípidos malos, tiene una hipercolesterolemia LDL muy elevada, por lo que requiere estatinas. Las mialgias, por lo general se estudian con CK. Si están normales, se evalúa mantener el tratamiento. Si están elevadas, se debe evaluar el riesgo / beneficio de la estatina. La rosuvastatina es de bajo riesgo de mialgias, al igual que la atorvastatina, por lo que, de las opciones, parece la más correcta, dado que los demás fármacos no son buenos para la hipercolesterolemia LDL.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 41 1.02.1.007 · Dislipidemias

Un paciente dislipidémico, está en tratamiento con atorvastatina 10 mg/día y se realiza un perfil lipídico de control con colesterol total: 183 mg/dl, colesterol HDL: 32 triglicéridos: 860 mg/dl. ¿Cuál es la dosis más adecuada?

A) Subir la dosis de la atorvastatina a 40 mg/día
B) Cambiar la atorvastatina por rosivastatina
C) Agregar gemfobrozilo 900 mg/día
D) Agregar ezetimibe al tratamiento
E) Reemplazar la atorvastatina por gemfibrozilo 900 mg/día

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La prioridad son los triglicéridos, por estar mayores a 500 mg/dl. No se pueden mezclar los fibratos con las estatinas, por el riesgo de rabdomiolisis (solo lo puede hacer el especialista).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 110 1.02.1.007 · Dislipidemias

Un paciente de 40 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión, asintomático, acude a control con perfil lipídico que muestra colesterol total 208, LDL 127, HDL 35, triglicéridos 230. El fármaco de elección para el tratamiento en este caso es:

A) Ácido nicotínico
B) Gemfibrozilo
C) Ácidos grasos omega 3
D) Colestiramina
E) Atorvastatina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por ser diabético, debe exigirse un LDL menor a 70. El LDL es la prioridad, si los TG están menores a 500. Si los TG hubiesen sido mayores a 500, ahí hubiese sido gemfibrozilo.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 89 1.02.1.007 · Dislipidemias

Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 3 meses, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9 mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídico que muestra triglicéridos: 250 mg/dL, colesterol total: 253 mg/dL, HDL: 51 mg/dL, LDL: 152 mg/dL. No presenta síntomas. El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:

A) Fibratos
B) Estatinas
C) Dieta baja en ácidos grasos saturados
D) Ácido nicotínico
E) Ezetimibe

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por ser diabético, su objetivo de LDL es menor a 100 o incluso menor a 70 según varias guías internacionales, por lo que está alto y se deben iniciar estatinas. Además, los TG está sobre 150, pero al ser menores a 500, no son la prioridad, sino que el LDL Lo es.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 8 1.02.1.007 · Dislipidemias

Paciente de 62 años, diabético diagnosticado hace 5 años en tratamiento con hipogli- cemiantes orales, como parte de un chequeo se realiza exámenes de chequeo donde se aprecia creatinina de 0,9mg/dL, hemoglobina glicosilada menor a 7% y un perfil lipídi- co que muestra triglicéridos de 250 mg/dL, colesterol total de 258 mg/dL, HDL 52 mg/dL, LDL 156 mg/dL. No presenta síntomas. El tratamiento más adecuado para disminuir su riesgo cardiovascular es:

A) Fibratos
B) Estatinas
C) Dieta baja en ácidos grasos saturados
D) Ácido nicotínico
E) Ezetimibe

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por ser diabético, se exige LDL menor a 100. Dado que los triglicéridos están meno- res a 500, el LDL es la prioridad.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 23 1.02.1.017 · Síndromes carenciales de v

Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿El déficit de qué nutriente explica mejor este caso?

A) Fierro
B) Ácido fólico
C) Cianocobalamina
D) Zinc
E) Tiamina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un déficit de B12, tanto por el antecedente de by-pass como por la macrocitosis y plaquetopenia. La ferritina está normal (VN: 15 a 300).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 25 1.02.1.017 · Síndromes carenciales de v

Una paciente de 34 años, con antecedente de by pass gástrico hace 2 años, por obesidad mórbida, consulta por astenia, disnea y marcada fatigabilidad y debilidad de extremidades inferiores. Al examen físico tiene paresia M4 de ambas extremidades inferiores, con disminución de la sensibilidad distal e hiporreflexia. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 20%, glóbulos blancos: 3.100 por mm3 y plaquetas: 93.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desnutrición proteica
B) Déficit de zinc
C) Déficit de fosfatos
D) Déficit de niacina
E) Déficit de cianocobalamina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un déficit de B12 clásico. Recordar que el déficit de B6 (piridoxina) es el causado por el consumo crónico de isoniazida (ej. TBC o PFX TBC) y se presenta como una polineuropatía.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 11 1.02.1.017 · Síndromes carenciales de v

Una paciente de 25 años, vegetariana estricta, con antecedente de un hijo con mielomeningocele, presenta anemia. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Vitamina B12
B) Folatos
C) Tiamina
D) Ácidos grasos omega 3
E) Aminoácidos esenciales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por ser vegetariana también debe recibir B12, pero los folatos son lo más importante por el mielomeningocele (defecto del tubo neural)

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 20 1.02.1.012 · Obesidad

Un adolescente de 16 años, con IMC de 33, se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 96 mg/dl, más una insulina basal que resulta 23 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar insulina
B) Iniciar dieta y ejercicio
C) Iniciar metformina
D) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa
E) Iniciar metformina más glibenclamida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene obesidad y resistencia a la insulina (HOMA = 96 x 23 / 405 = 5,5). No tiene ni diabetes, ni intolerancia a la glucosa, ni glicemia alterada de ayuno, así que solo se deja dieta y ejercicio.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 93 1.02.1.014 · Pié diabético y otras infe

DM con polineuropatía, dedos en garra, hiperqueratosis, con test de monofilamento alterado, pulsos disminuidos, conducta:

A) Mejorar calzado
B) Electromiografia, realizar test de nuevo en unos meses (esta era RX para descartar osteomielitis)
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mejorar calzado** (opción **A**). El tratamiento incluye descarga, debridamiento, antibióticos y control glicémico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 15 1.02.1.014 · Pié diabético y otras infe

Paciente masculino, de 50 años de edad, consulta por prurito intenso en el glande y al examen físico se constata eritema y edema en el glande y el prepucio, asociado a un anillo fibrótico en el prepucio. Refiere que ha tenido varios episodios similares antes. ¿A qué enfermedad se puede atribuir el cuadro?

A) Alcoholismo
B) Diabetes mellitus
C) VIH
D) Esclerodermia
E) Lupus

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Diabetes mellitus). Las balanopostitis candidiásicas se asocian a diabetes. También las candidiasis genitales femeninas.. El pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes y la principal causa de amputación no traumática de extremidades inferiores. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 74 1.02.1.014 · Pié diabético y otras infe

Un paciente de 60 años consulta por eritema y prurito en el glande y el prepucio. Al examen físico se constatan signos inflamatorios en dicha zona. Además de tratar la enfermedad descrita, ¿qué enfermedad sistémica se debe descartar?

A) Cáncer
B) Daño hepático crónico
C) Diabetes
D) Lupus
E) Insuficiencia renal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Diabetes). La balanopostitis (en especial la candidiásica) se asocia a diabetes.. El pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes y la principal causa de amputación no traumática de extremidades inferiores. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 16 1.02.2.002 · Cetoacidosis

Un joven de 14 años, deportista de alto rendimiento, consulta por un cuadro de poldipsia y poliuria de 3 semanas de evolución, al que hace 7 días se agrega astenia, náuseas y malestar general. Refiere marcada debilidad, después de realizar ejercicio. Se solicitan exámenes, en las que destaca glicemia: 312 mg/dl, Na+: 132 mEq/L, K+: 5,0 mEq/L, pH sanguíneo: 7,26, bicarbonato plasmático: 11 mEq/L, exceso de base: -13. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hiperglicemia secundaria al ejercicio
B) Cetoacidosis diabética
C) Debut de diabetes tipo 2
D) Diabetes insípida descompensada
E) Coma hiperosmolar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cetoacidosis diabética** (opción **B**). Es una cetoacidosis diabética clásica (acidosis metabólica y diabetes tipo 1).. Esta clase aborda la interpretación de la gasometría arterial enfocada en la función respiratoria, cubriendo tres parámetros fundamentales: la presión arterial de oxígeno (PaO2), la presión arterial de CO2 (PaCO2) y la diferencia alvéolo-arterial de oxígeno. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 101 1.02.2.002 · Cetoacidosis

Cetoacidosis cetonas (+) pH 7.1 K 3 conducta inicial hidratar SF

A) Observación clínica
B) Derivar a urgencia
C) Control ambulatorio
D) Solicitar exámenes complementarios
E) Hospitalizar para estudio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Observación clínica** (opción **A**). PaO2 normal: 75-100 mmHg. Hipoxemia: < 75 mmHg. Insuficiencia respiratoria: < 60 mmHg (equivale aprox. a SatO2 90%). De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 54 1.02.2.002 · Cetoacidosis

Un paciente de 20 años presenta un cuadro de poliuria y polidipsia, de 2 días de evolución, a lo que se ha agregado dolor abdominal y vómitos hace pocas horas. Se solicita una glicemia, que resulta 360 mg/dl. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

A) Cetonemia
B) Creatininemia
C) Perfil lipídico
D) Hemoglobina glicosilada
E) Hemograma

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Parece una cetoacidosis, así que lo más urgente es confirmar el diagnóstico, con la cetonemia (o cetonuria) y los gases venosos (para ver el estado ácido base). Los criterios son cetonas ++ en sangre u orina, pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 16 mEq/L y glicemia mayor o igual a 200 o 250 mg/dl (niños y adultos, respectivamente).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 166 1.02.1.002 · Diabetes gestacional

paciente con diabetes gestacional 28 semanas, con tto metformina pero con cifras elevadas de glicemia, se preguntaba cómo continuar tto

A) Pioglitazona
B) agregar insulina
C) Glibenclamida
D) Sitagliptina
E) Metformina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Pioglitazona). agregar insulina. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (agregar insulina, Glibenclamida) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 108 1.02.1.002 · Diabetes gestacional

Embarazada 24 semanas con glicemia post 75gr de glucosa en 200 ¿Cual es el manejo?

A) Iniciar insulina
B) Metformina
C) Glibenclamida
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar insulina** (opción **A**). Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 44 · 1.02.1.002 · Diabetes gestacional

Una paciente de 30 años, acude a su primer control de un embarazo de 10 semanas. Sus partos anteriores fueron eutócicos, con recién nacidos de término de 4 kilogramos. Entre sus exámenes de control trae un Elisa VIH que resultó negativo, hematocrito de 38%, glicemia de ayuno de 112 mg/dL y urocultivo negativo. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
B) Iniciar metformina oral
C) Repetir glicemia de ayuno
D) Repetir el urocultivo
E) Mantener el control embarazo normal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una diabetes gestacional (glicemia de ayuno mayor o igual a 100), por lo que se debe repetir. Si hubiese estado mayor o igual a 126 la sospecha sería una diabetes pregestacional, aunque la conducta sería la misma. Si no hubiese estado embarazada, se tendría que pedir un TTGO.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 88 · 1.02.1.002 · Diabetes gestacional

Una paciente de 22 años, acude a su primer control de un embarazo de 8 semanas. Entre sus exámenes trae un VDRL que resultó negativo, hematocrito de 39% y glicemia de ayuno de 112 mg/dL. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecua- da?

A) Solicitar test de tolerancia a la glucosa oral
B) Iniciar hipoglicemiantes orales
C) Repetir glicemia de ayuno
D) Solicitar insulinemia basal
E) Mantener el control embarazo normal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una glicemia de ayuno mayor o igual 100, lo que en el embarazo, obliga a re- petir la glicemia de ayuno.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 81 · 1.02.1.002 · Diabetes gestacional

Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y glicemia poscarga de 139 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la prueba de tolerancia a la glucosa a las 32 semanas
B) Iniciar metformina
C) Iniciar dieta hipoglucídica
D) Iniciar insulina
E) Mantener el control normal del embarazo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener el control normal del embarazo** (opción **E**). Tiene un TTGO normal (basal menor a 100 y postcarga menor a 140), por lo que se debe observar.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 133 · 1.02.1.002 · Diabetes gestacional

Una paciente de 36 años, cursando su primer embarazo a las 28 semanas, se reali- za un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucos, que arroja una glice- mia basal de 98 mg/dl y una glicemia postcarga, a las 2 horas, de 147 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Resistencia a la insulina
B) Diabetes mellitus gestacional
C) Diabetes mellitus pregestacional
D) Intolerancia a la glucosa oral
E) Embarazo normal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Diabetes mellitus gestacional** (opción **B**). Tienen un TTGO mayor o igual a 140, lo que en una mujer embarazada es DMG.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 133 · 1.02.1.002 · Diabetes gestacional

Una mujer de 34 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 205 a las 2 horas. Además de dieta y ejercicio, el tratamiento de elección es:

A) Acarbosa
B) Sitaglipina
C) Metformina
D) Insulina
E) Glibenclamida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La diabetes gestacional se trata con dieta y ejercicios y luego insulina como fármacos de elección. Si bien los hipoglicemiantes orales hoy pueden darse en el embarazo, la insulina sigue siendo de elección.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 158 · 1.02.4.024 · Test de tolerancia a la gl

Mujer asintomática de 46 años de edad, con IMC de 24. Tiene antecedente de diabetes gestacional con su último embarazo. Se practica una glicemia en ayunas que resulta en 112 mg/dl. La conducta más adecuada es:

A) Repetir la glicemia en ayunas
B) Practicar niveles de hemoglobina glicosilada
C) Indicar metformina
D) Realizar control de glicemia en 6 meses
E) Solicitar curva de tolerancia a la glucosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las glicemias de ayuno menores a 100, se observan; las entre 100 y 125 se solicita prueba de tolerancia a la glucosa. Las de 126 o más, se repiten. En el embarazo es distinto, así que siempre se debe leer si está o no embarazada, antes de contestar.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 104 · 1.02.4.024 · Test de tolerancia a la gl

Un paciente de 37 años, obeso, acude a control. En su examen Fsico se observa acantosis y oscurecimiento de la piel del cuello y axilas. Se solicitan exámenes generales entre los que destaca glicemia de ayuno de 120 mg/dL y colesterol total de 230 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar meeormina
B) Iniciar atorvasta2na
C) Iniciar aspirina
D) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral
E) Iniciar insulinoterapia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta algo discuGble. La glicemia entre 100 y 125 obliga a solicitar un TTGO (de 126 en adelante, se repite la glicemia). Si a las 2 horas el TTGO resulta 200 o más, se diagnostica una DM2; si está entre 140 y 199, se diagnostica una intolerancia a la glucosa; si solo muestra la glicemia basal entre 100 y 125, se diagnostica la glicemia de ayuno alterada. El colesterol en 230 obliga a solicitar un perfil lipídico, para saber cómo contribuyen el colesterol LDL, HDL y los triglicéridos. Además, probablemente sí cumple con criterios de síndrome metabólico, siendo adecuado iniciar la me~ormina, sin embargo, aún no está del todo claro y parece más razonable completar el estudio antes de iniciar tratamiento.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 95 · 1.02.4.024 · Test de tolerancia a la gl

Un paciente de 39 años, con antecedente de obesidad, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, que muestra una glicemia basal de 117 mg/dl y postcarga de 75 gramos de glucosa de 136 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Normal
B) Diabetes mellitus 2
C) Intolerancia a la glucosa oral
D) Diabetes mellitus 1
E) Prediabetes

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil, pero la glicemia de ayuno está en 117, es decir, tiene una glicemia de ayuno alterada (GGA). La glicemia poscarga está normal (menor a 140), por lo que no tiene intolerancia a la glucosa (IGO) ni diabetes (DM). La prediabetes se define como GAA, IGO o GAA + IGO, sin criterios de DM.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 149 · 1.02.2.006 · Hipoglicemias

Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulinodependien- te, en tratamiento con insulina NPH 30U en la mañana y 20 U en la noche. Presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitaciones intensas a las 3 de la madrugada, cons- tatándose un hemoglucotest de 50mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál

A) Disminuir la insulina NPH matinal
B) Suspender la insulina NPH matinal
C) Disminuir la insulina NPH nocturna
D) Suspender la insulina NPH nocturna
E) Disminuir ambas dosis de insulina NPH

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Está con hipoglicemias por insulina. La NPH nocturna es la que determina las gli- cemias a las 3 a.m., por lo que se debe disminuir esa.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 72 · 1.02.2.006 · Hipoglicemias

Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida 15 mg/día, presenta convulsiones tónico-clónicas subintrantes desde hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de ayuno de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?

A) Hipomagnesemia
B) Hipernatremia
C) Hipoglicemia
D) Hipocalcemia
E) Cetoacidosis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La glibenclamida tiene alto riesgo de hipoglicemia. Además, este es el típico caso en que el paciente mal controlado decide "autorreforzar" su tratamiento, después de que los exámenes le salen mal, produciendo hipoglicemias. Que haya tenido glicemia alta antes, no impide que ahora esté baja. De las demás opciones, solo la hiponatremia produce convulsiones con cierta frecuencia.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 86 · 1.02.2.006 · Hipoglicemias

Un paciente de 78 años, diabético, en tratamiento con glibenclamida, presenta convulsiones tónico- clónicas subintrantes hace algunos minutos. Hace 3 días se realizó control de exámenes, con glicemia de 185 mg/dl y electrolitos plasmáticos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la causa más probable de sus convulsiones?

A) Hipomagnesemia
B) Hipernatremia
C) Hipoglicemia
D) Hipocalcemia
E) Cetoacidosis (nota: subintrante significa que comienza una nueva crisis, antes de recuperarse por completo de la anterior)

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto por la clínica, como por el antecedente de glibenclamida, lo más probable es que tenga hipoglicemias (probablemente se sintió mal de haber estado mal controlado e intentó arreglar sus glicemias subiendo la dosis de GBC).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 119 · 1.02.2.006 · Hipoglicemias

Un paciente de 60 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 insulinodependiente, en tratamiento con insulina NPH 30 U en la mañana y 20 U en la noche, presenta un cuadro de malestar, sudoración y palpitaciones intensas a las 3 de la madrugada, que respondió a la ingesta de azúcar, constatándose un hemoglucotest de 50 mg/dL. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Disminuir la insulina NPH matinal
B) Modificar los horarios de las insulinas
C) Disminuir la insulina NPH nocturna
D) Suspender la insulina NPH nocturna
E) Disminuir ambas dosis de insulina NPH

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Disminuir la insulina NPH nocturna** (opción **C**). Frente a descompensación metabólica aguda, cetoacidosis o hiperglicemia severa refractaria, la insulinoterapia endovenosa continua con monitorización seriada de electrolitos (especialmente potasio) es la piedra angular del manejo.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 73 1.02.2.006 · Hipoglicemias

Hombre de 50 años operado de bypass gástrico hace 1 año. Consulta por episodios de sudoración, temblor y mareo 2 horas después de las comidas. Glicemia capilar durante el episodio: 52 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Úlcera marginal
B) Obstrucción de la anastomosis
C) Dumping tardío (hipoglicemia reactiva postprandial)
D) Hipoglicemia por insulinoma
E) Síndrome de asa aferente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Dumping tardío: hipoglicemia 1-3h postprandial por liberación exagerada de insulina tras la hiperglicemia inicial del dumping precoz. Exclusivo del bypass gástrico. Tratamiento: comidas pequeñas y frecuentes, reducción de carbohidratos simples, acarbosa.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 40 1.02.2.006 · Hipoglicemias

Un paciente de 67 años, diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina 1700 mg/día y glibenclamida 20 mg/día, ambos separados en dos dosis diarias consulta por episodios repetidos de mareos, malestar y sudoración, asociado a temblor, que ocurren al final de la mañana o antes de almuerzo. Han coincidido con glicemias capilares de 65 mg/dl. Su IMC es 32 Kg/m2. Su hemoglobina A1c resulta 8,1. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender la glibenclamida
B) Agregar una colación con 25 gramos de hidrato de carbono antes del almuerzo
C) Suspender la glibenclamida
D) Reemplazar la glibenclamida por sitagliptina
E) Reemplazar la metformina por pioglitazona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene clínica de hipoglicemias, que probablemente son causadas por la glibenclamida. Por eso se debe cambiar por otro hipoglicemiante. Como tiene un mal control metabólico (HbA1c alta), no se debe agregar la colación

---

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 42 1.02.1.016 · Síndrome metabólico

Un paciente de 30 años, con IMC: 30 Kg/m2 consulta por hoperpigmentación de la piel de las axilas y el cuello, asociado a aparición de acrocórdones en plieguen inglinales, cervicales y en las axilar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Cushing
B) Hipotiroidismo
C) Síndrome paraneoplásico
D) Insuficiencia suprarrenal
E) Resistencia a la insulina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Resistencia a la insulina** (opción **E**). Tiene acantosis nigricans, clásico de la RI.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 176 1.02.1.003 · Diabetes mellitus pregesta

Una mujer cursa un embarazo de 10 semanas y se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 128 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Prediabetes
B) Diabetes mellitus gestacional
C) Glicemia de ayuno alterado
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Intolerancia a la glucosa oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien le falta otra glicemia de ayuno mayor o igual a 126, para confirmar el diagnóstico, sobre dicho valor se sospecha una diabetes pregestacional.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 107 1.02.1.003 · Diabetes mellitus pregesta

Una paciente embarazada de 10 semanas, se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glicemia normal para el embarazo
B) Intolerancia a la glucosa oral
C) Diabetes mellitus gestacional
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Resistencia a la insulina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
SI bien tiene solo una toma de glicemia, dos glicemias de ayuno mayores o iguales a 126, en un embarazo menor a 12 semanas es una DMPG. Si estuvieran entre 100 y 125 sería DMG.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 180 1.02.1.003 · Diabetes mellitus pregesta

Una paciente embarazada de 9 semanas, se realiza una glicemia de ayuno en su control del embarazo, que resulta 130 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glicemia normal para el embarazo
B) Intolerancia a la glucosa
C) Diabetes mellitus gestacional
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Prediabetes

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una mala pregunta, porque solo dan 1 glicemia, lo que no diagnostica nada. Sin embargo, se considera diabetes pregestacional que haya 2 glicemias de ayuno mayores o iguales a 126, a inicio del embarazo. Así mismo, se considera diabetes gestacional, si las dos glicemias son mayores o iguales a 100, pero menores a 126.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 4 1.02.3.002 · Anorexia nerviosa

Una paciente de 25 años, con antecedente de anorexia nervosa desde hace 5 años. Ac- tualmente pesa 29 kilos y mide 1,68 metros, con IMC de 10,3. ¿Con cuantas kilocalorías diarias se debe iniciar su alimentación?

A) 300
B) 600
C) 1200
D) 1500
E) 2400

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (300). Para prevenir el síndrome de realimentación se debe iniciar con 10-15 Kcal/Kg/día. Pésima pregunta.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 106 1.02.4.017 · Hemoglobina glicosilada

Un paciente de 66 años es hospitalizado por una neumonía adquirida en la comunidad. En su hemoglucotest de ingreso, se constata una glicemia capilar de 256 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes exámenes confirma el diagnóstico de diabetes?

A) Glicemia de ayuno > 126 mg/dl
B) Prueba de tolerancia a la glucosa > 200 mg/dl, postcarga de glucosa
C) Hemoglobina glicosilada > 6,5%
D) Prueba HOMA > 2,6
E) Albuminuria/creatininuria > 0,3

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

[Pregunta disputada] Tanto B, como C cumples criterios de diabetes. No queda claro qué es lo que se quiere preguntar. Como ahora está con una neumonía, la PTGO puede salir falsamente alterada, en cambio la HbA1c es más estable (por lo que la consideraremos correcta). Sin embargo, la HbA1c no está dentro de los critesios diagnósticos de la guía Minsal. Es una mala pregunta.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 24 1.02.1.006 · Diabetes por corticoides

Mujer de 55 años con DM2 en tratamiento con metformina, requiere corticoterapia con prednisona 40 mg/día por enfermedad pulmonar. Sus glicemias de ayuno eran 130 mg/dL y post-prandiales suben a 280 mg/dL. ¿Cuál es el ajuste más adecuado?

A) Iniciar insulina
B) Agregar metformina adicional
C) Pioglitazona
D) Glibenclamida
E) Sitagliptina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Corticoides causan hiperglicemia postprandial marcada por resistencia a la insulina. La insulina es el tratamiento de elección en este contexto (flexibilidad de ajuste, control rápido). Los hipoglicemiantes orales no dan el control necesario con dosis altas de corticoides.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 106 1.02.1.006 · Diabetes por corticoides

Asmática con crisis tratada con corticoides VO por 5 días, al 5to día se le solicita seguimiento con exámenes, presenta glicemia 130. Cuál es la conducta más apropiada

A) Repetir glicemia en 1 semana
B) Pedir hemoglobina glicosilada
C) Solicitar PTGO
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Pedir hemoglobina glicosilada** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 93 1.02.1.006 · Diabetes por corticoides

Un paciente de 35 años, con antecedente de obesidad y resistencia a la insulina, presenta una reacción alérgica severa relacionada con el uso de fármacos, por lo que es hospitalizado para manejo con soporte y cor8coides sistémicos. Durante su hospitalización se realizan exámenes entre los que destaca glicemia de 180 mg/dL, que se man8ene en rangos similares en varias tomas. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnós8co?

A) Pép2do C
B) Test de tolerancia a la glucosa oral
C) Hemoglobina glicosilada
D) Índice de HOMA
E) Insulinemia postcarga de glucosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien la regla general es que una glicemia mayor o igual a 126 se repite, esto cambia cuando hay un descompensante agudo (ej. infecciones, corticoides, la misma reacción alérgica), en que dio descompensante puede alterar tanto la glicemia, como la prueba de tolerancia a la glucosa. Por esto, en esos casos de elección es la hemoglobina glicosilada, que refleja las glicemias de los úlGmos 2 a 3 meses. El normal de la HbA1c es 4% a 6%. Desde 6,5% es diagnóstica de diabetes. Actualmente se considera un examen adecuado para el diagnóstico en pacientes estables también. Es el examen de elección para el seguimiento del control metabólico.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 169 1.02.1.006 · Diabetes por corticoides

Paciente hospitalizada con hidrocortisona endovenosa y glicemias elevadas persistentes. ¿Cuál es el examen para el diagnóstico?

A) Glicemia en ayunas
B) Test de tolerancia oral a la glucosa
C) Insulinemia basal
D) Hemoglobina glicosilada (HbA1c)
E) Péptido C

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Hemoglobina glicosilada (HbA1c)** (opción **D**). Hemoglobina glicosilada (HbA1c). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 95 1.02.1.006 · Diabetes por corticoides

Un paciente de 53 años es hospitalizado por una reacción alérgica grave, recibiendo adrenalina e hidrocortisona endovenosa. Durante la hospitalización se realizan múltiples exámenes, entre los que destacan glicemias de ayuno muy elevadas, en rangos entre 160 y 180 mg/dl. ¿Qué examen es más adecuado para determinar la etiología de esta alteración?

A) Péptido C
B) Anticuerpos anti GAD
C) Hemoglobina glicosilada
D) Test de tolerancia a la glucosa oral
E) Tomografía axial computada pancreática

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Test de tolerancia a la glucosa oral). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Péptido C, Anticuerpos anti GAD) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 22 · 1.02.2.004 · Déficit agudo de tiamina

Hombre con antecedente de cirugía bariátrica hace 1 año+consumo de OH desde hace 7 meses, deja de asistir a control médico, parte con 1 semana de evolución de ataxia, dificultad de la marcha, visión doble,confusión, somnolencia, cual es la deficiencia:

A) Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda. Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).
B) Vitamina B12
C) Vitamina C
D) Laparotomía exploratoria
E) Cirugía laparoscópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Tiamina, Wernicke, llevaba solo un año desde la Cx y la presentación de síntomas era más aguda. Tenia triada de wernicke: encefalopatía, oftalmoplejía y ataxia (COCA como le dice Guevara).). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 77 · 1.02.2.005 · Hipertrigliceridemia grave

Un paciente de 45 años, obeso (con IMC:35) y diabético, en tratamiento con metformina y empaglifozina y con antecedente de consumo de 4 cervezas diarias, acude a chequeo. Trae múltiples exámenes, entre los que destaca perfil lipídico con colesterol LDL: 135 mg/dl, colesterol HDL: 27 mg/dl y triglicéridos: 1.000 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente en este momento?

A) Enviar al servicio de urgencias
B) Iniciar gemfibrozilo 900 mg/día
C) Iniciar rosuvastatina 40 mg/día
D) Iniciar ezetimibe 10 mg/día
E) Iniciar dieta estricta

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de Hipertrigliceridemia Severa: En un paciente con dislipidemia mixta el objetivo suele ser bajar el colesterol LDL, a menos que los triglicéridos sean > 500 mg/dL, en que la prioridad es bajar los triglicéridos. Con niveles > 1000 mg/dL, hay alto riesgo de pancreatitis, por lo que se debe manejar urgentemente. Hace años incluso se recomendaba hospitalizarlos para el manejo, sin embargo esa recomendación actualmente está obsoleta (tal vez el Eunacom aún la considera). La medida más importante o urgente es la suspensión inmediata del consumo de alcohol y una dieta estricta baja en glúcidos y baja en grasas. En paralelo, se inician los fibratos (gemfibrozilo)..

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 78 · 1.02.4.015 · Glicemia capilar

Un paciente de 57 años, diabético desde hace 15 años, en tratamiento con metformina 1 gramo cada 12 horas e insulina NPH nocturna 10 UI por vía subcutánea. Respecto al control con glicemias capilares, ¿cuál es el esquema de control más adecuado?

A) Controlar dos horas después del desayuno
B) Controlar dos horas después del almuerzo
C) Controlar a primera hora en la mañana, en ayunas
D) Controlar antes de cada comida
E) Controlar antes de la administración de la insulina NPH nocturna

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Control de la Diabetes Tipo 2: La forma óptima de controlar la diabetes tipo 2 es con la hemoglobina glicosilada, aunque es útil conocer las glicemias pre y postprandiales para ajustar las dosis de insulina. En pacientes con insulina NPH nocturna, la glicemia de ayuno a primera hora de la mañana es el parámetro más importante a evaluar, aunque nunca está de más conocer los valores del resto de glicemias pre y post comidas.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 39 · 1.02.2.003 · Coma hiperosmolar

Un paciente de 70 años presenta un cuadro de malestar general y poliuria de dos semanas de evolución, agregándose desorientación y compromiso de conciencia cuan8ta8vo en las úl8mas 48 horas. En su examen, no presenta focalidad neurológica y sus laboratorios revelan glicemia: 950 mg/dL, pH venoso: 7,37, bicarbonato: 18 mEq/L, cetonemia (-), cetonuria (+), sodio plasmá8co: 149 mEq/L y potasio plasmá8co: 5,0 mEq/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Coma hiperosmolar no cetósico
B) Cetoacidosis diabé2ca
C) Síndrome hiperglicémico mixto (hiperosmolar + cetoacidosis)
D) Hipernatremia sintomá2ca
E) Edema cerebral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un síndrome hiperglicémico hiperosmolar (Sd. HGHO) clásico, cuyo otro nombre es “coma hiperosmolar no cetósico”. No hay acidosis (cetoacidosis requiere pH < 7,3 y HCO3 < 15 mEq/L). Se puede estimar la osmolaridad con una fórmula (Osmolaridad = 2xfía + BUN/2,8 + glicemia/18, que en este caso, sin tomar en cuenta el BUN ya da 350 mOsm/L), sin embargo, suele bastar una glicemia mayor a 600 para que con alVsima probabilidad cumpla el criterio de la osmolaridad > 320 mOsm/L, propio del Sd. HGHO).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 30 · 1.02.3.006 · Prevención de Diabetes Mel

Hombre de 48 años con glicemia de ayuno de 115 mg/dL en dos ocasiones. IMC 28. Sin otros factores de riesgo. ¿Cuál es la intervención más importante para reducir la progresión a diabetes?

A) Dieta estricta baja en carbohidratos
B) Metformina 500 mg dos veces al día
C) Ejercicio aeróbico 150 minutos por semana
D) Orlistat
E) Insulina basal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Prediabetes (glucosa ayuno 100-125 mg/dL): la intervención más efectiva para prevenir progresión es el cambio de estilo de vida: ejercicio ≥150 min/semana de intensidad moderada + dieta saludable. Reduce riesgo de DM en 58% (estudio DPP). Metformina es segunda línea en pacientes de alto riesgo.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 124 · 1.02.1.015 · Retinopatía diabética

pte diabetico con fondo de ojo alterado tenia buen control metabolico, cual era la medida mas adecuada

A) Pioglitazona
B) Sitagliptina
C) Insulina NPH
D) Glibenclamida
E) subir metformina??

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Glibenclamida). subir metformina??. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera adquirida en adultos en edad laboral. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

ENDOCRINOLOGÍA & METABOLISMO

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 07

94 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

22 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.03.1.002	Hipotiroidismo	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	9 Q	Tomo 07 · C.2 (Pág. 8)
1.03.1.003	Hipertiroidismo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 17 · 17.6 (Pág. 24)
1.03.1.005	Tiroiditis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.006	Síndrome de Cushing	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 07 · C.8 (Pág. 20)
1.03.1.007	Insuficiencia suprarrenal crónica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 07 · C.9 (Pág. 22)
1.03.1.008	Hirsutismo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.009	Hipertensión arterial de origen endocrino	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.010	Amenorrea	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.012	Hipogonadismo masculino	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.013	Tumores hipofisiarios	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.014	Hipopituitarismo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.015	Diabetes insípida	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 07 · C.17 (Pág. 38)
1.03.1.016	Hiperprolactinemia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.018	Osteoporosis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 07 · C.34 (Pág. 72)
1.03.1.020	Hipercalcemias e hipocalcemias	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	10 Q	Tomo 07 · C.21 (Pág. 46)
1.03.1.021	Nódulo tiroídeo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	15 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.1.023	Ginecomastia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)
1.03.2.002	Mixedema	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 07 · C.4 (Pág. 12)
1.03.2.003	Insuficiencia suprarrenal aguda	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 07 · C.5 (Pág. 14)
1.03.2.004	Hipercalcemia aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 07 · C.6 (Pág. 16)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.03.2.005	Tetania	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 07 · C.7 (Pág. 18)
1.03.4.004	T4 libre	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 07 · Endocrinología (Pág. 8)

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 18 1.03.1.006 · Síndrome de Cushing

Una paciente de 28 años aumento de peso de 5 meses de evolución, asociado a malestar general. Refiere importante astenia, que ha progresado y debilidad muscular. Al examen físico presenta PA: 150/100 mmHg, atrofia de las masas musculares de las extremidades, obesidad abdominal y piel con estrías vinosas en la pared abdominal e hirsutismo en cara, abdomen y pecho. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Niveles de ACTH plasmático matinal y vespertino
B) 17 hidroxiprogesterona
C) TAC de silla turca
D) Cortisol libre urinario de 24 horas
E) Prueba de estimulación con ACTH

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Cortisol libre urinario de 24 horas). El síndrome de Cushing se estudia de elección con el cortisol libre urinario de 24 horas.. El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 27 1.03.1.006 · Síndrome de Cushing

Una paciente de 13 años, sin antecedentes, consulta por cefalea e hirsutismo. Al examen físico se encuentra presión arterial en percentil 99 para su edad, índice de masa corporal mayor al percentil 95 para su edad, acné inflamatorio en su rostro y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:

A) Diabetes mellitus tipo 2
B) Síndrome de ovario poliquístico
C) Síndrome de Cushing
D) Hipotiroidismo
E) Hiperprolactinemia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome de Cushing** (opción **C**). De libro. El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 159 1.03.1.006 · Síndrome de Cushing

Una paciente de 29 años consulta por aumento de peso de 10 kg en un año, a pesar de seguir una dieta. Refiere también que sus reglas se han vuelto irregulares y cada vez son menos frecuentes. En su examen Fsico se observa obesidad y estrías en el abdomen y los muslos, de color rojizo. Sus signos vitales muestran FC: 72 lpm y PA: 150/96 mmHg. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar el estudio de esta paciente?

A) Cor2sol plasmá2co a las 7:00 y a las 23:00 horas
B) Cor2sol plasmá2co post-dexametasona
C) Niveles plasmá2cos de ACTH
D) Resonancia magné2ca nuclear de abdomen
E) Resonancia magné2ca nuclear de hipófisis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un síndrome de Cushing, cuyo estudio sigue los siguientes pasos: Primero: Se inicia con cualquiera de 3 exámenes (algunas guías recomiendan pedir más de uno desde el inicio): 1. CorGsol libre urinario de 24 horas, 2. Prueba de supresión corta (mide corGsol basal y post dexametasona, con dosis baja) y 3. CorGsol en saliva. Segundo: Una vez confirmado el hipercorGsolismo, se conGnúa el estudio con la prueba de supresión larga (más dosis de dexametasona) y niveles plasmáticos de ACTH. Tercero: Si los resultados orientan a un tumor hipofisiario (suprime y/o ACTH elevada), se solicitar una imagen hipofisiaria (RMN). En cambio, si orientan a una causa suprarrenal (no suprime y/o ACTH baja), se solicita una imagen suprarrenal (RMN o TAC).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 169 1.03.1.006 · Síndrome de Cushing

Una mujer de 34 años, con amenorrea de 6 meses, presenta un cuadro de astenia y malestar general. Además refiere equimosis ante mínimos traumatismos. Actualmente tiene PA: 150/90 mmHg, acné facial, cuello ancho, obesidad centrípeta y estrías violáceas. Tiene prueba de embarazo negativa. ¿Cuál es la prueba a realizar en primer lugar?

A) Cortisol plasmático basal
B) FSH y estradiol plasmático
C) Cortisol libre urinario
D) Prueba de estimulación con ACTH
E) Resonancia magnética de silla turca

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El síndrome de Cushing se estudia primeramente con cortisol libre urinario de 24 horas. También hubiese sido correcto un test de supresión corta con dexametasona o el cortisol en saliva, si es que no hubiese estado la opción del CLU 24 horas. Si están alterados, se prosigue el estudio con ACTH y prueba de supresión larga. La RMN de silla turca, se pide más adelante, en caso de que la ACTH sea alta y la prueba de supresión larga suprima parcialmente. La prueba de estimulación con ACTH sirve para la insuficiencia suprarrenal (ej. Addison).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 43 1.03.1.006 · Síndrome de Cushing

Una paciente de 16 años, obesa, consulta por astenia y debilidad de semanas de evolución, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se corrobora obesidad en percentil 97 para la edad, se aprecia hirsutismo, acné inflamatorio y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:

A) Resistencia insulínica
B) Síndrome de ovario poliquístico
C) Síndrome de Cushing
D) Diabetes Mellitus tipo 1
E) Hiperprolactinoma

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome de Cushing** (opción **C**). Es la misma pregunta de antes.. El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 111 1.03.1.016 · Hiperprolactinemia

Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos combinados orales, desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y se objetiva la galactorrea al comprimir las mamas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar niveles de progesterona
B) Solicitar niveles de prolactina
C) Cambiar los anticonceptivos a progestágenos solos
D) Solicitar TAC de cerebro
E) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar niveles de prolactina** (opción **B**). Tiene una hiperprolactinemia. No tiene la amenorrea clásica, porque usa anticonceptivos.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 79 1.03.1.016 · Hiperprolactinemia

Una paciente de 26 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por historia de tres meses de amenorrea asociada a galactorrea, sin otros síntomas, con prueba de detección de bHCG en orina negativa en dos oportunidades. Su examen físico resulta normal, su índice de masa corporal es de 20. El examen de elección para iniciar el estudio en este caso es:

A) Hormona estimulante tiroidea
B) Prueba de progesterona
C) Ecografía transvaginal
D) Prolactina
E) Prueba de estrógeno más progesterona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Prolactina). Síndrome amenorrea galactorrea, sin embarazo, es hiperprolactinemia.. 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 72 1.03.1.016 · Hiperprolactinemia

Una paciente de 35 años, usuaria de T de cobre desde hace 5 años, consulta porque, desde hace 8 meses está en amenorrea. Al examen físico tiene galactorrea bilateral a la compresión del pezón, sin otras alteraciones en el examen ginecobstétrico ni en el examen físico general. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Niveles plasmáticos de HCG
B) Resonancia magnética de silla turca
C) Niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH, FSH y TSH
D) Ecografía transvaginal
E) Prolactinemia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH, FSH y TSH). 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Niveles plasmáticos de HCG, Resonancia magnética de silla turca) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 131 1.03.1.016 · Hiperprolactinemia

Una paciente de 25 años, sin antecedentes de importancia, consulta por mastalgia bilateral de 5 días de evolución. Al examen físico, se observa galactorrea bilateral al comprimir los pezones. Su FUR fue hace 12 días y no toma medicamentos. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio?

A) Subunidad beta de gonadotropina coriónica humana en plasma
B) Prolactinemia
C) Resonancia magnética de silla turca
D) Ecotomografía mamaria
E) Mamografía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Galactorrea y Amenorrea: Ante una paciente con galactorrea y amenorrea, lo primero es descartar embarazo. Luego, se busca hiperprolactinemia, cuya causa principal son los medicamentos (no en este caso, en que no utiliza medicamentos) y, luego, los adenomas hipofisarios. La última regla fue hace 12 días, lo que reduce la probabilidad de embarazo. Sin embargo, es fundamental descartarlo con una prueba de gonadotropina coriónica humana en plasma.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 77 1.03.1.016 · Hiperprolactinemia

Una paciente de 26 años consulta por dolor mamario bilateral, de 3 semanas de evolución. Su FUR fue hace 12 días. Al examen físico tiene galactorrea bilateral, sin nódulos. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio en esta paciente?

A) Resonancia magnética de mama
B) Ecografía mamaria
C) Prolactinemia
D) Niveles de gonadotropina coriónica
E) Resonancia magnética de silla turca

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

[Pregunta disputada] Pregunta muy discutible, ya que hay dos respuestas potencialmente correctas: la C y la D. La galactorrea se estudia 1. descartando embarazo y 2. luego prolactinemia. Dado que su FUR fue hace 8 días da a entender que no está embarazada y, por tanto, la respuesta debería ser prolactinemia. Sin embargo, también están las máximas descarte siempre embarazo primero y no le crea a la FUR. Finalmente, el dolor mamario con congestión sugiere algo más embarazo que un prolactinoma. En fin, así es el Eunacom. Si bien en la clase les dije que marcaran la C, hoy amanecí marcando la D; la volvimos a discutir con varios ginecólogos y las opiniones estuvieron divididas, aunque tendió a ganar descartar el embarazo. Si encuentran esta pregunta, sigan su corazón, marquen la que más los convenza a ustedes y sigan.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 167 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Un paciente de 30 años, presenta un nódulo tiroideo, que en el examen físico se palpa de consistencia elástica, indoloro, sin adenopatías cervicales. Se solicita TSH: 0,2 UI/L (VN: 0,3 a 5,0 UI/L), con T4 y T3 normales. Se solicita ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo sólido, redondo, de aspecto homogéneo, sin microcalcificaciones, de 3 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cintigrafía tiroidea
B) Realizar punción con aguja fina
C) Controlar con pruebas tiroideas en 6 meses
D) Solicitar niveles de tiroglobulina
E) Realizar cirugía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta difícil, ya que el manejo general del nódulo tiroideo es 1. solicitar TSH (y T4 libre), 2. solicitar ecografía tiroidea (puede ser simultáneamente con la TSH), 3. si tiene más de 10 mm, solicitar PAAF. Sin embargo, la excepción es cuando está hipertiroideo, en que se debe pedir una cintigrafía tiroidea: como en este caso que la TSH está baja y, por tanto, tiene un hipertiroidismo subclínico (con T4 normal). Si es un nódulo caliente (hipercaptante), se diagnostica el adenoma tóxico y se debe extirpar. Si es frío (capta igual o menos que el resto de la tiroides), se procede a la punción.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 51 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia y piel seca. Al examen se detecta un nódulo tiroideo, que se palpa de 15 mm de diámetro, en relación al lóbulo derecho. Se solicita TSH y T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

A) Ecografía cervical
B) Biopsia citológica por punción con aguja fina
C) Biopsia excisional
D) Cintigrafía tiroidea
E) Captación de yodo radiactivo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El nódulo tiroideo se inicia su estudio con la ecografía cervical. Se continúa el estudio, de acuerdo a lo explicado en la pregunta 23. Si bien igual probablemente se hará pa biopsia citológica por punción, el examen inicial sigue siendo la ecografía.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 38 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Un paciente se realiza una ecografía de cuello, como parte del estudio de un nódulo cervical, que visualiza un tumor sólido y redondeado, localizado en el istmo, de 4 mm de diámetro, sin presencia de adenopatías. Sus pruebas tiroideas muestram TSH y T4 libre dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?.

A) Iniciar tratamiento levotiroxina
B) Iniciar levotiroxina en dosis de supresión
C) Realizar punción con aguja fina
D) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
E) Realizar seguimiento ecográfico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar seguimiento ecográfico** (opción **E**). Al ser un nódulo tan pequeño, no está indicada la punción (mayor a 10 mm se puncionan).. Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 154 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Paciente con antecedente de AVE isquémico; en ecografía Doppler carotídeo se ve nódulo tiroideo de 10 mm, quístico, bordes regulares, sin vascularización. ¿Cuál es la conducta?

A) PAAF del nódulo
B) Cintigrafía tiroidea
C) Derivar a cirugía de cuello
D) Controlar con ecografía en un año
E) TSH y T4 libre

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Controlar con ecografía en un año** (opción **D**). Controlar con ecografía en un año. Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 16 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Un paciente de 32 años, con antecedente de familiar con cáncer de tiroides, acude a la consulta. Trae una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro de aspecto quístico, sin calcificaciones, con presencia de adenopatías inespecíficas pequeñas. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar punción aspiración con aguja fina
B) Solicitar cintigrafía tiroidea
C) Solicitar captación de yodo radiactivo
D) Solicitar nueva ecografía en 6 meses
E) Realizar tiroidectomía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los nódulos menores a 10 mm, en especial si son quísticos, se observan, debido a que con altísima probabilidad son un quiste coloideo. Se controla ecográficamente en 6 meses.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 17 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia y piel seca. Al examen se detecta un nódulo tiroideo, que se palpa de 15 mm de diámetro, en relación al lóbulo derecho. Se solicita TSH, que resulta: 3,5 UI/L y T4 libre de 1,2 ng/dl. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

A) Ecografía cervical
B) Biopsia citológica por punción con aguja fina
C) Resonancia magnética nuclear de cuello
D) Cintigrafía tiroidea
E) TAC de cuello

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un nódulo tiroideo eutiroideo (TSH normal: 0,4 a 4,0; T4 libre normal: 0,7 a 1,9). Por tanto, se debe seguir su estudio con ecografía y luego la PAAF. Si hubiese estado hipertiroideo, se debería realizar la cintigrafía.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 23 · 1.03.1.021 · Nódulo tiroídeo

Un paciente de 32 años, con antecedente de madre con cáncer de tiroides, por lo que se realiza una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro y aspecto quístico. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar punción aspiración con aguja fina
B) Solicitar cintigrafía tiroidea
C) Solicitar captación de yodo radiactivo
D) Solicitar nueva ecografía en 6 meses
E) Realizar tiroidectomía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Todo nódulo tiroideo se estudia con Ecografía y TSH + T4L. Si tiene más de 10 mm, se punciona con PAAF. Si tiene menos de 10 mm, se sigue (este caso). Si tiene TSH baja (hipertiroidismo) se estudia con cintigrafía toroidea.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 101 · 1.03.1.021 · Nódulo tiroídeo

Un hombre de 59 años, fumador, presenta un accidente vascular encefálico, que se maneja rápidamente, por lo que se recupera sin dejar secuelas. Posteriormente, se realiza ecografía Doppler carotidea como estudio de fuente embólica, que no muestra alteraciones arteriales, pero sí identifica la presencia de un nódulo tiroideo de 1 cm de diámetro, de aspecto quístico, bien delimitado y capsulado. Se solicitan pruebas tiroideas que muestran TSH: 2,1 microU/ml (VN: 0,5 a 5,0) y T4 libre que resulta 1,2 ng/dl (VN: 0,9 a 2,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del nódulo tiroideo?

A) Realizar punción con aguja fina
B) Controlar en 6 meses con nueva ecografía
C) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
D) Iniciar levotiroxina
E) Realizar biopsia excisional quirúrgica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar punción con aguja fina** (opción **A**). Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 65 · 1.03.1.021 · Nódulo tiroídeo

Un paciente de 50 años consulta porque notó aumento de volumen en la zona anterior de su cuello. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro y consistencia dura. Se solicitan exámenes, entre los que destaca una TSH: 6,2 UI/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?

A) T4 libre
B) Ecografía cervical
C) Cintigrafía tiroidea
D) Estudio citológico por punción
E) Anticuerpos antitiroideos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Estudio del nódulo tiroideo: El algoritmo para el estudio de un nódulo tiroideo comienza con la medición de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Si la TSH está suprimida, lo que indica hipertiroidismo, el siguiente paso es realizar una gammagrafía tiroidea para determinar si el nódulo es la causa del hipertiroidismo. Un nódulo caliente en la gammagrafía confirma el diagnóstico de adenoma tóxico. Si la TSH es normal o elevada, como en este caso, se debe realizar una ecografía cervical para evaluar las características anatómicas del nódulo. La ecografía permite clasificar el nódulo según el sistema TI-RADS. Un TI-RADS 1 indica un nódulo normal, un TI-RADS 2 indica un nódulo benigno, un TI-RADS 3 o 4 indica un nódulo sospechoso (con mayor grado de sospecha en el TI-RADS 4) y un TI-RADS 5 indica un nódulo altamente sospechoso de malignidad. Los nódulos sospechosos (TI-RADS 3 o 4) mayores a 10 mm se estudian mediante punción aspiración con aguja fina (PAAF), que es lo mismo que biopsia citológica. Los nódulos altamente sospechosos de malignidad (TI-RADS 5) se deben biopsiar independientemente de su tamaño, aunque la biopsia puede ser difícil de realizar en nódulos menores a 5 mm. Los TI-RADS 2 se observan, independientemente del tamaño.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 22 · 1.03.1.021 · Nódulo tiroídeo

Un paciente de 28 años, fumador, consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa nódulo paratraqueal derecho, de 3 cm de diámetro y consistencia aumentada, que asciende con la deglución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste tirogloso
B) Quiste branquial
C) Cáncer de laringe
D) Adenopatía metastásica
E) Nódulo tiroideo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Ascienden con la deglución solo la el QTG y el nódulo tiroideo. Pero el QTG está en la línea media y no en el lado derecho, como este caso.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 92 · 1.03.1.021 · Nódulo tiroídeo

Mujer de 37 años, sin antecedentes, consulta por aparición de aumento de volumen cervical anterior, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca nódulo a nivel tiroídeo de consistencia aumentada, que asciende a la deglución. Como parte del estudio se realiza TSH que resulta normal. La conducta inicial más adecuada en este caso es:

A) Solicitar punción con aguja fina
B) Solicitar Cintigrafía con I131
C) Solicitar ecografía cervical
D) Solicitar anticuerpos anti tiroperoxidasa
E) Solicitar niveles de T3 y T4L

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Eco y PAAF son respuestas correctas. Como no dice el tamaño, primero la ecografía, para ver el aspecto y descartar adenopatías. Así lo dice la guía minsal.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 25 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Una paciente de 25 años presenta un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, a la palpación. Se solicita TSH t T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

A) Ecografía cervical
B) Punción aspiración con aguja fina
C) Anticuerpos antiroideos
D) Cintigrafía con yodo radiactivo
E) TAC cervical

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Ante un nódulo tiroideo, lo primero es pedir TSH, luego la ecografía y luego la punción con aguja fina (si es mayor a 10 mm).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 34 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Un paciente de 36 años consulta por aumento de volumen en la zona anterior del cuello. Al examen físico tiene un nódulo duro, de 2 cm de diámetro, asociado a una adenopatía cervical anterior de consistencia dura. Se solicita una TSH que resulta 6,1 UI/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

A) Punción con aguja fina
B) Ecografía tiroidea
C) Cintigrafía con yodo radiactivo
D) TAC de cuello
E) Resonancia magnética nuclear de cuello

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
A? Por regla general, la ecografía cervical es el primer examen para un nódulo tiroideo y por eso creo que es la respuesta correcta. Sin embargo, ya cumple criterios de punción con aguja fina (mayor a 15 mm con TSH normal o alta).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 146 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Una paciente de 42 años, consulta por adenopatía supraclavicular derecha persis- tente. Al examen físico se palpa además un nódulo cervical paratraqueal derecho de consistencia amentada, que asciende con la deglución, de alrededor de 2 cm de diáme- tro. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de esta paciente?

A) Niveles plasmáticos de calcitonina
B) Ecografía cervical
C) TAC de cuello
D) Resonancia magnética de cuello
E) Biopsia quirúrgica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Ecografía cervical). Todo nódulo cervical se estudia inicialmente con Ecografía de cuello.. El nódulo tiroideo es frecuente y su importancia radica en descartar cáncer de tiroides y adenoma tóxico. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 20 1.03.1.021 · Nódulo tiroideo

Hipertiroidismo con nódulo tioideo sólido en ecografía, de 2.5 cm + TSH 0.7. Con qué examen continuar estudio: a. Cintigrama tiroideo

B) PAAF
B) Hemograma y VHS
C) Ecografía
D) Radiografía
E) TAC con contraste

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). El nódulo tiroideo es frecuente y su importancia radica en descartar cáncer de tiroides y adenoma tóxico. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 124 1.03.1.015 · Diabetes insípida

Niño operado de cirugía cerebral, luego presenta hipernatremia y poliuria. ¿Diagnóstico más probable?

A) Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)
B) Diabetes mellitus tipo 1
C) Hiperaldosteronismo secundario
D) Diabetes insípida central
E) Polidipsia psicogénica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Diabetes insípida central** (opción **D**). Diabetes insípida central. El SIADH se produce por exceso de hormona antidiurética, que retiene agua y causa hiponatremia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 80 1.03.1.015 · Diabetes insípida

Hombre con poliuria, polidipsia y nicturia. Toma 8 lts de agua al dia. En los exámenes destaca hiponatremia, como inicia el estudi n o?:

A) Ecografía renal
B) Electrolitos urinarios (no puede ser esta? Dice estudio inicial, se necesita la osm urinaria y luego deprivar y comparar o no??? -> Pero estudio de deprivación incluye la medición de OsmU y NaU pre y post deprivación), es esta, salía en ensayos anteriores
C) TAC de no se q
D) Test de deprivación de agua (esto es para hipernatremia sg yo)
E) Derivar a psiquiatría f. PTGO

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Electrolitos urinarios (no puede ser esta? Dice estudio inicial, se necesita la osm urinaria y luego deprivar y comparar o no??? -> Pero estudio de deprivación incluye la medición de OsmU y NaU pre y post deprivación), es esta, salía en ensayos anteriores). El SIADH se produce por exceso de hormona antidiurética, que retiene agua y causa hiponatremia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 105 1.03.1.015 · Diabetes insípida

Una paciente de 16 años de edad, con cuadro caracterizado por polidipsia y poliuria desde hace aproximadamente 3 semanas, no asociado a otros síntomas. Se realizan exámenes donde destaca osmolaridad plasmática disminuida, por lo que se solicita test de la sed que muestra normalización de diuresis y osmolaridad plasmática. El diagnóstico más probable es:

A) Polidipsia psicógena
B) Diabetes insípida nefrogénica
C) Diabetes insípida central
D) Hipercalcemia
E) Diabetes mellitus tipo 1

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Polidipsia psicógena** (opción **A**). Sd. polidípsico-poliúrico, pero se normaliza con el test de la sed.. El SIADH se produce por exceso de hormona antidiurética, que retiene agua y causa hiponatremia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 30 1.03.1.005 · Tiroiditis

Una paciente de 23 años, consulta por malestar general y sensación febril de una semana de evolución, asociado a artralgias y palpitaciones. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L (valor normal: 0,3-4,5 UI/L), T4L: 1,9 ng/mL (valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (valor normal: 20% a 30%). ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?

A) Tiamazol
B) AINEs
C) Propiltiouracilo
D) Bloqueadores beta
E) Yodo radioactiivo en dosis terapéutica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una tiroiditis subaguda de Quervain, cuyo tratamiento son los AINEs. No se usan las drogas antitiroideas y no sirve el yodo radiactivo (de hecho, no capta). El betabloqueo sí se usa cuando hay síntomas de hiperT4, pero lo más importante son los AINEs.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 114 1.03.1.005 · Tiroiditis

Una paciente de 30 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cuadro de 8 días de sudoración, palpitaciones e insomnio, que durante los últimos días se ha asociado a dolor en región cervical anterior. Al examen físico se aprecia con frecuencia cardiaca de 100 por minuto, presión arterial 140/90, dolor a la palpación cervical. Se solicitan exámenes donde destaca T4 y T4L aumentadas y TSH suprimida, electrocardiograma normal. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Propiltiouracilo
B) Paracetamol
C) Metimazol
D) Ketoprofeno
E) Enalapril

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una tiroiditis subaguda de Quervain, que se trata con AINEs. No se deben indicar drogas antitiroideas (PTU, metimazol) y sí se puede dar propanolol si hay muchos síntomas de hipertiroidismo. El paracetamol no es suficiente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 10 1.03.1.005 · Tiroiditis

Una paciente de 33 años, consulta por dolor cervical intenso de una semana de evo- lución asociado a sensación febril. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,2 UI/L, T4L: 1,9 ng/mL (Valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (Valor normal: mayor a 3%). ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?

A) Propiltiouracilo
B) Ibuprofeno
C) Prednisona
D) Levotiroxina
E) Yodo radioactiivo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ibuprofeno** (opción **B**). Es una tiroiditis subaguda de Quervain, que se trata con AINEs. Tratamiento de Quervain: AINEs + betabloqueo. NO metimazol. Corticoides solo si síntomas sistémicos graves. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 115 1.03.1.005 · Tiroiditis

Una paciente usuaria de anticonceptivos y con antecedentes familiares de hipotiroidismo, consulta por aumento de volumen en el cuello. Al examen físico, la tiroides se palpa aumentada de tamaño, sin nódulos. Los exámenes revelan una TSH: 2,0 UI/L, T4: 14,0 ug/dl (valor normal: 4,5 a 9,5), anticuerpos antitiroglobulina: 48 UI/ml (valor normal: <35) y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea: 320 UI/ml (valor normal: <35). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar T4 libre
B) Solicitar ecografía tiroidea
C) Solicitar una cintigrafía tiroidea
D) Realizar control de TSH y T4 en un año
E) Realizar biopsia tiroidea por punción

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiroiditis de Hashimoto Eutiroidea: El diagnóstico más probable en esta paciente es tiroiditis de Hashimoto, ya que presenta bocio y elevación de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Si bien la T4 está elevada, esto se debe al uso de anticonceptivos, que elevan la TBG. En las pacientes que utilizan anticonceptivos, se debe utilizar la T4 libre en lugar de la T4 total. El valor normal de la TSH descarta la presencia de hipertiroidismo. El manejo de la tiroiditis de Hashimoto eutiroidea, como en este caso, consiste en realizar un control frecuente con pruebas tiroideas anuales para detectar y tratar precozmente el eventual hipotiroidismo.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 160 1.03.1.005 · Tiroiditis

Una paciente consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de fiebre, sudoración nocturna, temblor, malestar general y artralgias. Hace 7 días se agrega dolor en el cuello. Al examen físico tiene marcado dolor a la palpación de la glándula tiroides. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 2,9 ng/dl, con captación de yodo radiactivo de 1% (VN: 2 a 40%). El tratamiento más adecuado es:

A) Paracetamol
B) Antibióticos
C) Prednisona
D) Metimazol
E) Ketoprofeno

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una clásica tiroiditis subaguda o tiroiditis de Quervain, que se trata con AINEs. Solo si es que tiene muchos síntomas hipertiroideos se agrega el propanolol. No están indicadas las drogas antitiroideas (metimazol o propiltiouracilo).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 19 1.03.1.010 · Amenorrea

Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina, que están dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:

A) Prolactinoma
B) Falla ovárica primaria
C) Embarazo ectópico
D) Amenorrea hipotalámica
E) Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico (las gonadotropinas normales se consideran como hipogonadotrófico), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria (el hipo- hipo es hipo-hipo).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 153 1.03.1.010 · Amenorrea

Una paciente de 16 años, sin antecedentes, es traída por no presentar aún menarquia, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia talla de 1.53 metros y desarrollo puberal tanner 1, sin otros hallazgos. Se realiza test de progesterona que resulta negativo. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Anovulación
B) Malformación uterina
C) Hipopituitarismo
D) Hipotiroidismo
E) Síndrome de turner

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene retraso puberal, talla de 1,53 metros (no es talla baja propiamente tal, pero es una talla que no descarta Turner) y probablemente un hipogonadismo. No tiene clínica de hipopituitarismo (hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal), sino solo del hipogonadismo. Todo hipogonadismo en una niña es un Turner, hasta que se demuestre lo contrario, en particular si es baja.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 175 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Un paciente de 32 años, con antecedente de litiasis renal a repetición se realiza exámenes, que muestran calcio plasmático: 9,8 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, PTH: 90 UI/L (VN: 10 a 55 pg/ml) y calciuria de 200 mg/día (VN: 50 a 150 mg/día) . El diagnóstico más probable es:

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hiperparatiroidismo secundario
C) Hiperparatiroidismo terciario
D) Hipercalciuria primaria
E) Hipercalciuria familiar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene hipercalcemia, con elevación de la PTH, así que se confirma el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario. El secundario tiene la calcemia baja o normal y suele ser por IRC. El terciario es igual al primario, pero en un paciente con IRC, que tenía uno secundario y luego empezó a tener hipercalcemia, en lugar de la hipocalcemia del secundario. La hipercalcemia maligna tiene PTH baja. La hipercalciuria primaria sí tiene litiasis, pero la PTH y la calcemia son normales. El hiperparatiroidismo primario tiene hipercalciuria secundaria y, por ello, se produce la litiasis también.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 32 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

En el estudio de una osteoporosis de una paciente, se pesquisa tiene calcemia de 11 mg/dl, niveles de paratohormona de 155 UI/L (VN: 15 a 55), niveles de vitamina D: (VN:) y albúmina de 3,8 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipercalcemia idiopática
B) Hiperparatiroidismo primario
C) Hiperparatiroidismo secundario
D) Hiperparatiroidismo terciario
E) Hipercalcemia familiar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hiperparatiroidismo primario** (opción **B**). Calcio alto y PTH alta son característicos del HPP.. Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 8 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Mujer de 58 años con calcio sérico de 11.8 mg/dL detectado en examen de rutina. Asintomática. Sin uso de suplementos de calcio ni vitamina D. ¿Cuál es el estudio inicial de elección para determinar la causa de la hipercalcemia?

A) PTH sérica
B) Fósforo sérico
C) Calcitonina
D) Calcio en orina de 24h
E) Vitamina D (25-OH)

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
PTH es el primer examen a solicitar en hipercalcemia: PTH elevada = hiperparatiroidismo primario (causa más frecuente en ambulatorio). PTH suprimida = hipercalcemia de malignidad, intoxicación vitamina D u otras causas. Orienta todo el estudio.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 167 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Hombre de 55 años asintomático con calcio sérico 11.2 mg/dL, fósforo 2.1 mg/dL (bajo) y PTH 145 pg/mL (elevada). Sin otros hallazgos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
C) Hipercalcemia de malignidad
D) Intoxicación por vitamina D
E) Sarcoidosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hipercalcemia + hipofosforemia + PTH inapropiadamente elevada en paciente asintomático = hiperparatiroidismo primario. Es la causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios. PTH suprimida en malignidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 78 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5- 10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?

A) Cintigrafía ósea
B) Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Niveles plasmáticos de vitamina D
E) Resonancia magnética de abdomen y pelvis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una hipercalcemia, con la posibilidad de ser secundaria al cáncer. Igualmente se estudia con PTH, ya que si está elevada es un hiperparatiroidismo primario y si está baja, es probablemente un cáncer.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 121 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Un paciente de 67 años consulta por dolores óseos en múltiples zonas. Se realiza exámenes, entre los que destaca calcemia corregida de 14,4 mg/dl, con pruebas de función renal normales. Además, se solicitan radiografías que muestran imágenes sugerentes de metástasis óseas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Calciuria de 24 horas
B) Niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D
C) Niveles plasmáticos de paratohormona
D) Cintigrafía ósea
E) Niveles plasmáticos de calcio iónico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque tenga imágenes de metástasis, también pueden ser causadas por un hiperparatiroidismo primario (HPP). Por eso es que la hipercalcemia se estudia siempre con PTH: si está elevada es un HPP y si está baja es cáncer. La cintigrafía ósea es una forma de buscar metástasis que no se han visto (en este caso ya las vio la radiografía) y se pide, por ejemplo, en la etapificación del cáncer de próstata con APE mayor a 20; sin embargo, es inespecífica, porque también se altera con otros procesos de hiperactividad ósea (osteoclástica), como el HPP.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 33 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Una paciente presenta su sexta litiasis urológica, por lo que se realizan exámenes, entre los que destacan creatinina: 1,2 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, calcio: 11 mg/dl, fósforo: 2,3 mg/dl, natremia normal, potasemia normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico?

A) Paratohormona
B) LH y FSH
C) 25 OH vitamina D
D) Biopsia de médula ósea
E) Índice proteinuria / creatininuria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Paratohormona** (opción **A**). La hipercalcemia se estudia con PTH. Además, la hipofosfemia orienta a un HPP.. Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 89 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Un paciente de 35 años ha presentado 6 episodios, en el último año, de litiasis renal por cálculos cálcicos. ¿Qué alteración endocrinológica puede ser causante de esto?

A) Hipercortisolismo
B) Hipocortisolismo
C) Hiperprolactinemia
D) Hiperparatiroidismo
E) Hipoparatiroidismo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El hiperparatiroidismo produce salida de calcio desde los huesos, lo que aumenta la calcemia y también la calciuria, produciendo litiasis urológica.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 177 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

Un paciente de 50 años, sin antecedentes, acude a realizarse un chequeo, asintomático. Su examen físico es normal. Trae exámenes que se habría tomado la semana pasada donde destaca hemoglobina 14 mg/dL, leucocitos 7.000/mm3, plaquetas 230.000/mm3, creatinina 0.8 mg/dL, calcio 11, albúmina 4, electrocardiograma normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Mantener control ambulatorio anual
B) Solicitar cintigrafía ósea
C) Solicitar radiografía de huesos largos y huesos parietales
D) Solicitar niveles de paratohormona
E) Solicitar electroforesis de proteínas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar niveles de paratohormona** (opción **D**). Tiene el Calcio elevado (N menor a 10,5). Corregido por albúmina queda igual. Se debe pedir PTH.. Hiperparatiroidismo primario: tratamiento quirúrgico (tumorectomía o paratiroidectomía con implante) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 172 1.03.1.020 · Hipercalcemias e hipocalce

¿Cual es el estudio de Hipercalcemia ? a. Calcemia y PTH 173. Había un AM con alteraciones de memoria creo, con VCM > 100: B12 (ALGUIEN RECUERDA ALGO DE ESTO)

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Hemograma y VHS). Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Ecografía, Radiografía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 109 1.03.1.014 · Hipopituitarismo

Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y permaneciendo en amenorrea. Presenta un cuadro de astenia, adinamia y malestar general, asociada a debilidad. Tiene piel seca, con cabello quebradizo, palidez y su presión arterial es de 90/60 mmHg. El diagnóstico más probable es:

A) Tiroiditis postparto
B) Panhipopituitarismo
C) Depresión postparto
D) Insuficiencia ovárica
E) Hipotiroidismo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Panhipopituitarismo** (opción **B**). Es un síndrome de Sheehan clásico, que cursa con hipopituitarismo.. El hipopituitarismo se define como la hipoproducción de hormonas hipofisiarias. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 48 1.03.1.014 · Hipopituitarismo

Un hombre de 49 años presenta un cuadro de algunos meses de evolución de astenia, disminución de la libido y de potencia sexual, además de náuseas, mialgias y malestar general. Refiere, con cierta preocupación, que ha chocado con algunos muebles, por no haberlos visto, mientras caminaba en su casa. Al examen físico, tiene FC: 65x', PA: 108/66 mmHgm, T°: 35,8°C, presenta piel seca y fría, disminución del vello corporal, examen cardiopulmonar normal y abdomen sin alteraciones. En el examen neurológico destaca afectación temporal del campo visual. ¿Cuál es el examen de elección para evaluar a este paciente?

A) Niveles plasmáticos de hormona tiroestimulante
B) Radiografía de silla turca
C) Tomografía axial computarizada de suprarrenales
D) Niveles de testosterona y prolactina
E) Resonancia magnética nuclear de silla turca

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Niveles plasmáticos de hormona tiroestimulante). El hipopituitarismo se define como la hipoproducción de hormonas hipofisiarias. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 36 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Un paciente se realiza una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspende el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. ¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examem físico?

A) Mixedema pretibial
B) Exoftalmo
C) Melanoplaquias
D) Piel seca
E) Acantosis nigricans

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El hipotiroidismo se caracteriza por la piel seca. El mixedema pretibial y exoftalmo son de la enfermedad de Basedow Graves, las melanoplaquias de la enfermedad de Addison y la acantosis nigricans, de la resistencia a la insulina.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 15 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Una paciente de 27 años, en amenorrea por lactancia, presenta un cuadro de astenia y malestar general, constipación y dificultades para concentrarse, asociado a intolerancia al frío. Además, refiere que no ha podido bajar de peso. Al examen físico tiene FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, se aprecia piel seca y cabello ralo, sin otras alteraciones en el examen físico segmentario. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran TSH: 14,7 UI/L, T4 libre: 0,6 ng/dl, T3: 46 ng/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Iniciar tratamiento con levotiroxina oral
B) Solicitar ecografía tiroidea
C) Solicitar cintigrafía tiroidea
D) Solicitar prueba de captación de yodo radiactivo
E) Repetir los exámenes en 6 semanas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un hipotiroidismo clínico tanto por los síntomas como por la T4 libre baja (normal: 0,7 a 1,9), por lo que debe iniciar levotiroxina. Además, incluso si hubiese sido subclínico, la TSH sobre 10 obliga a iniciar la levotiroxina.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 173 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Una paciente de 27 años consulta por un cuadro clínico de un año de evolución caracterizado por astenia, adinamia, malestar general. Además, ha aumentado 8 kg de peso y, en el último mes presenta sensación de frío, constipación y mialgias. Al examen físico presenta lentitud en el lenguaje verbal y razonamiento, piel seca y fría con vitíligo en la cara y manos y alopecia moderada en el cuero cabelludo. Su frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto y su presión arterial, de 130/80 mmHg. Se constata edema bilateral de extremidades inferiores, sin fóvea. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Hemograma - VHS
B) Colonoscopía
C) Niveles de cortisol
D) TAC de cerebro
E) TSH

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Evaluación del Hipotiroidismo Severo: En un paciente con sospecha de hipotiroidismo severo, la evaluación inicial debe incluir la medición de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y, idealmente, también la T4 libre. El manejo del coma mixedematoso (una complicación grave del hipotiroidismo) consiste en la administración de corticosteroides y levotiroxina intravenosos. En este caso, aún no tiene un coma mixedematoso.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 105 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Un paciente de 84 años se realiza una TSH, que resulta 8,4 UI/L. La TSH se repita 3 meses después, resultando 9,2 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar propiltiouracilo oral
B) Iniciar levotiroxina oral 25 ug/día
C) Iniciar tiamazol
D) Iniciar corticoides orales
E) Iniciar levotiroxina oral 75 ug/día

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un hipotiroidismo subclínico o clínico (no daban la T4 libre, por lo que no se puede saber). Sin embargo, de las opciones, la única que tenía sentido era iniciar levotiroxina y, por ser una adulto mayor, se debe iniciar con una dosis más baja.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 110 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Una paciente de 35 años presenta un cuadro de astenia importante. Al examen físico tiene FC: 59x', PA: 110/70 mmHg, se aprecia palidez, ictericia, vitiligo, edema de EEII, piel seca, con pelo quebradizo. En sus exámenes tiene hematocrito: 27%, con VCM: 110. El diagnóstico más probable es:

A) Depresión
B) Daño hepático crónico
C) Déficit de vitamina B12
D) Enfermedad de Addison
E) Hipotiroidismo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Hipotiroidismo** (opción **E**). Cuadro clásico. El hipopituitarismo se define como la hipoproducción de hormonas hipofisiarias. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 172 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Una paciente de 27 años consulta por astenia, adinamia, malestar general de un año de evolución, aumento de 8 kg de peso, sensación de frío, constipación y mialgias. Al examen: lentitud en lenguaje y razonamiento, piel seca y fría, vitíligo en cara y manos, alopecia moderada, FC 60 lpm, PA 130/80 mmHg, edema bilateral de extremidades inferiores sin fóvea. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Hemograma - VHS
B) Colonoscopía
C) Niveles de cortisol
D) TAC de cerebro
E) TSH

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hipotiroidismo severo: En sospecha de hipotiroidismo, el examen inicial es la TSH (idealmente con T4 libre). El cuadro clínico con bradicardia, mixedema, piel seca, constipación, aumento de peso y lentitud psicomotora es altamente sugerente de hipotiroidismo severo.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 21 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Una paciente de 17 años, con hábitos de vida sedentarios y obesidad se realiza exámenes de control, en los que presenta TSH: 6,5 UI/L, T4 libre: 1,5 ng/dl (VN: 0,7 a 1,9 ng/dl) y T3 libre 300 pg/dl (VN: 130 a 450 pg/dl). La conducta más adecuada es:

A) Inicial levotiroxina
B) Controlar hormonas tiroideas en 6 meses
C) Solicitar anticuerpos antiperoxidasa tiroidea
D) Solicitar ecografía tiroidea
E) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un hipotiroidismo subclínico, sin complicaciones, por lo que no requiere tratamiento y se debe observar.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 136 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

Un paciente de 64 años consulta por astenia y mialgias de 3 meses de evolución. Se solicita TSH, que resulta 5,6 UI/L y T4 libre, que resulta 1,2 ug/ml (Valor Normal: 0,95 a 1,75 ug/ml). La conducta más adecuada es:

A) Solicitar ecografía cervical
B) Iniciar levotiroxina
C) Solicitar TSH y T4 libre en 3 meses
D) Indicar punción tiroidea
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy discutible, ya que el diagnóstico es un hipotiroidismo subclínico y el manejo de esta patología está llena de controversias. Los niveles de TSH y T4 libre de este paciente no justifican los síntomas. Lo más correcto sería seguir estudiando la causa de la astenia y mialgias. Dentro de las opciones, sería válida iniciar tratamiento, si la pregunta se refiere a un hipoT4 sintomático (y por lo tanto clínico), pero probablemente no se refiere a eso, por tener una TSH de apenas 5,6. Por el contrario, sería controlar con pruebas tiroideas, si se refiere a un hipotiroidismo subclínico propiamente tal y decidir el manejo con levotroxina solo si persiste con los niveles elevados de TSH en 3 meses y con los síntomas, o si se asocia algún otro factor de riesgo, como dislipidemia, depresión.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 119 1.03.1.002 · Hipotiroidismo

¿Cuál es la conducta más adecuada ante una paciente embarazada en el primer trimestre, que presenta una TSH de 4,5 UI/L?

A) Iniciar propiltiouracilo
B) Solicitar T4 libre
C) Iniciar levotiroixina
D) Solicitar una nueva TSH en un mes
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy discutible, ya que el manejo del hipoT4 subclínico en el embarazo es algo que no está zanjado en la discusión médica y que distintas guías entregan distintas recomendaciones, incluyendo las guías Minsal, que son contradictorias entre sí. Sin embargo, la recomendación es la siguiente: 1. El objetivo de TSH en el embarazo es de 0,4 a 2,5 UI/L y 2. hay que tratar el hipoT4 subclínico en el embarazo.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 112 1.03.1.007 · Insuficiencia suprarrenal

Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome paraneoplásico
B) Desnutrición proteica
C) Enfermedad de Addison
D) Cáncer de sitio no precisado
E) Pancreatitis crónica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una insuficiencia suprarrenal por TBC. Es la segunda causa de Addison, después de la causa autoinmune. En FB alguien puso K: 2,9 y en ese caso sería un síndrome de secreción ectópica de ACTH, que tiene una clínica totalmente distinta y que es un síndrome paraneoplásico.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 102 · 1.03.1.007 · Insuficiencia suprarrenal

Un paciente alcohólico, en situación de calle, con antecedente de una tuberculosis tratada hace 2 años, consulta por astenia de 3 meses de evolución, asociada a debilidad muscular, dolor abdominal y diarrea. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 90/60 mmHg y presenta hiperpigmentación en los pliegues y melanoplaquias. Entre sus exámenes destaca creatinina: 1,0 mg/dl, sodio: 131 mEq/L, potasio: 5,6 mEq/l, cloro: 94 mEq/l, hematocrito: 35% y blancos: 7.500 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome paraneoplásico
B) Cáncer de origen desconocido
C) Enfermedad de Addison
D) Daño hepático crónico
E) Tuberculosis renal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una insuficiencia suprarrenal primaria clásica, probablemente secundaria a tuberculosis suprarrenal (segunda causa, después de la autoinmune). Tiene la hiperpigmentación, la hipotensión, la hipoNa+ y la hiperK+ clásicas.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 113 · 1.03.1.013 · Tumores hipofisiarios

Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz y las manos. También ha aumentado el número de sus zapatos. ¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio de este paciente?

A) Niveles de hormona de crecimiento
B) Radiografías de pies y de la arcada dentaria
C) Radiografía de manos
D) Niveles de IGF-1
E) Resonancia magnética de hipófisis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La acromegalia se estudia primero con somatomedina 1 o IGF1 (son sinónimos). La GH es muy errática y no se pide.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 138 · 1.03.1.013 · Tumores hipofisiarios

Una paciente cefalea de 4 semanas de evolución, mayor en las mañanas, que se asocia a vómitos y, además, refiere alteraciones visuales. Al examen físico tiene fuerzas y sensibilidad conservada en las 4 extremidades y en el campo visual se constata hemianopsia bitemporal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tumor de la glándula pineal
B) Glioma del nervio óptico
C) Tumor de la base del lóbulo frontal
D) Hiperprolactinemia
E) Macroadenoma hipofisiario

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome de hipertensión endocraneana más compresión del quiasma óptico, por lo que se trata de un tumor hipofisiario compresivo.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 111 · 1.03.1.013 · Tumores hipofisiarios

Un paciente consulta por disminución del deseo sexual y de las erecciones. Además, presenta astenia y debilidad, que ha ido aumentando, desde hace algunos meses. También, refiere haber chocado con un mueble, por no haberlo visto, resultado con lesiones. Al examen físico se aprecia pálido, con disminución del vello corporal, tiene edema de extremidades inferiores y disminución de la visión en la zona temporal del campo visual. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de este paciente?

A) Radiografía de silla turca
B) Prolactinemia
C) Resonancia magnética de silla turca
D) Fondo de ojo
E) TAC de cerebro

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un tumor hipofisiario clásico, con síntomas compresivos del quiasma e hipopituitarismo. Se estudia con RMN de silla turca.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 32 · 1.03.1.013 · Tumores hipofisiarios

Un paciente de 30 años presenta astenia, malestar general y sudoración nocturna desde hace dos meses. Al examen Fsico registra frecuencia cardíaca: 89 lpm, presión arterial: 130/90 mmHg, se observa progna8smo y dedos de las manos gruesos. ¿Cuál de las siguientes hormonas estará elevada con mayor probabilidad?

A) Tiroxina
B) Factor de crecimiento insulínico 2po 1 (IGF-1)
C) FSH
D) Tirotropina (TSH)
E) ACTH

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es una acromegalia, que se produce por un tumor hipofisiario productor de GH (somatotrofina u hormona de crecimiento). Sin embargo, el examen de elección es el IGF-1 (insulin growth factor 1, también llamado somatomedina 1) .

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 123 · 1.03.1.013 · Tumores hipofisiarios

Paciente con astenia, disminución de la libido, disfunción eréctil progresiva y alteración visual en zonas temporales. ¿Cuál es el examen de elección?

A) RNM de silla turca
B) Campo visual computarizado
C) TAC de cerebro con contraste
D) Testosterona total sérica y FSH/LH
E) Ecografía testicular bilateral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (RNM de silla turca). RNM de silla turca. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Campo visual computarizado, TAC de cerebro con contraste) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 24 1.03.1.013 · Tumores hipofisiarios

Una paciente de 32 años, consulta por un cuadro de 6 meses de amenorrea, asociado a secreción mamaria bilateral. No utiliza método anticonceptivo y es sexualmente activa. Además, ha presentado cefalea que ha aumentado en las últimas semanas, de predominio matinal. Al examen mamario se objetiva escasa galactorrea y al examen neurológico se constata presencia de una hemianopsia bitemporal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Craneofaringioma
B) Macroadenoma hipofisiario
C) Glioma cerebral
D) Apoplejía hipofisiaria
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Macroadenoma hipofisario: La hemianopsia bitemporal sugiere una compresión del quiasma óptico, y el síndrome de amenorrea-galactorrea indica hiperprolactinemia. En conjunto, estos síntomas apuntan a un macroadenoma hipofisario como el diagnóstico más probable. Es importante diferenciarlo de la apoplejía hipofisaria, que se caracteriza por una cefalea intensa y aguda, acompañada de signos de compresión en la silla turca, como hemianopsia bitemporal y parálisis de los nervios oculomotores.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 39 1.03.1.013 · Tumores hipofisiarios

Un paciente presentó varios episodios de mareos y sudoraciones, objetivándose una hipoglicemia severa de 35 mg/dl en la más grave. Se realiza un test de ayuno y a las 9 horas

A) Hepatoma
B) Hipoglicemia facticia por insulina
C) Hipoglicemia facticia por sulfonilúreas
D) Insulinoma
E) Hipoglicemia reactiva idiopática

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene hipoglicemias de ayuno y no reactiva. La insulina alta es compatible con B, C y D, pero el péptido C suprimido no es compatible con insulinoma ni sulfonilúreas, por lo que obligatoriamente es por insulina exógena.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 114 1.03.1.018 · Osteoporosis

Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -2,7 en la cadera derecha y de -2,8 en la columna lumbar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar ejercicio aeróbico
B) Indicar reposo relativo
C) Aumentar dosis de vitamina D y calcio
D) Agregar bifosfonatos al tratamiento
E) Mantener el tratamiento

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene osteoporosis (T score menor o igual a -2,5). Se deben iniciar los bifosfonatos. Se mantiene el calcio y la vit D

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 110 1.03.1.008 · Hirsutismo

Una paciente de 17 años, con antecedente se haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene hirsutismo en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?

A) Relación FSH/LH
B) Cariograma
C) Curva de insulina
D) Prolactina
E) 17-hidroxi-progesterona

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
[Pregunta disputada] No se entiende qué es lo que se quería pregunta. La 17-OH progesterona permite diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita, que es el diagnóstico diferencial del SOP más importante y que también tiene mucho hirsutismo. Por otro lado, la relación LH/FSH elevada sugiere un SOP, aunque no se usa como criterio, por tener muchos falsos negativos.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 115 1.03.1.008 · Hirsutismo

Una paciente de 17 años, con antecedente se haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene vello en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. Su examen mamario y genital son normales. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?

A) Relación FSH/LH
B) Cariograma
C) Curva de insulina
D) Niveles plasmáticos de prolactina
E) 17-hidroxi-progesterona

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **17-hidroxi-progesterona** (opción **E**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 115 1.03.1.008 · Hirsutismo

Una paciente de 17 años, con IMC de 34, presenta oligomenorrea, desde su primera mesntruación. Además tiene acné y se observa hirsutismo en la cara, los pezones e intermamario. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Testosterona plasmática
B) Andrógenos totales
C) Prueba de progesterona
D) Índice de andrógenos libres
E) 17 hidroxiprogesterona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un SOP ya diagnosticado (cumple 2 criterios: oligomenorrea y el hiperandrogenismo cínico), por tanto no es necesario pedir ningún examen. No aparecía como alternativa, así que hay que pedir índice de andrógenos libres, que es el examen de eleción para evaluar el hiperandrogenismo en el SOP).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 59 1.03.1.009 · Hipertensión arterial de o

Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K:2.6 mEq/L, Cl:90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:

A) Hipertensión renovascular
B) Feocromocitoma
C) Hipotiroidismo
D) Hiperaldosteronismo
E) Hipertensión esencial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un hiperaldosteronismo clásico. La hipertensión renovascular también puede presentar hipokalemia (porque produce un hiperaldosteronismo secundario, por activación de eje renina – angiotensina – aldosterona), pero el resto de la clínica calza mejor con hiperaldosteronismo primario (mucha debilidad, calambres y cefalea). En cambio, la HTA RV tiene soplo abdominal y algo de elevación de la creatininemia.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 45 1.03.1.009 · Hipertensión arterial de o

Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia, debilidad muscular y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico se observa obeso, con PA: 170/100 mmHg, FC: 70 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K: 2.6 mEq/L, Cl:100 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. La causa más probable de la hipertensión es:

A) Hipertensión renovascular
B) Feocromocitoma
C) Hipotiroidismo
D) Hiperaldosteronismo primario
E) Hipertensión esencial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un HAP clásico, por la hipokalemia y la sintomatología asociada a dicha hipokalemia. Eso sí, la HTA RV también tiene hipokalemia, así que, si tuviera soplo, antecedentes CV (que den estenosis renal) o hubiese estado HAP en las opciones, la RV habría sido la respuesta.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 121 1.03.1.009 · Hipertensión arterial de o

Un paciente de 37 años es diagnosticado de hipertensión hace un año, en tratamiento con enalapril, atenolol e hidroclorotiazida, a pesar de lo cual ha presentado valores tensionales sobre el objetivo, con varias tomas sobre 160/110 mmHg. Además, aqueja astenia, debilidad de las extremidades inferiores y cefalea frecuente. Se solicitan exámenes generales, que muestran TSH: 6,0 UI/L, creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 142 mEq/L, potasio: 3,1 mEq/L, hemograma normal y glicemia de ayuno: 72 mg/dl. Se solicita TAC de abdomen, que muestra un tumor suprarrenal derecho, de 2 cm de diámetro, sólido y homogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Feocromocitoma
B) Hipertensión esencial
C) Hipertensión renovascular
D) Hipertensión asociada a insuficiencia renal
E) Hiperaldosteronismo primario

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hiperaldosteronismo primario** (opción **E**). Clase sobre diagnóstico, objetivos y pilares del tratamiento de la hipertensión arterial. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 32 1.03.1.009 · Hipertensión arterial de o

Un paciente de 35 años consulta por cefalea y debilidad muscular de algunos meses de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 160/110 mmHg, sin otros hallazgos. Se solicitan exámenes que muestran creatininemia de 0,9 mg/dl, sodio: 138 mEq/l, potasio: 3,0 mEq/l y cloro: 98 mEq/l. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

A) Doppler de arterias renales
B) Holter de presión arterial
C) Determinación de metanefrinas urinarias
D) Relación aldosterona / actividad de renina plasmática
E) Cortisol libre urinario de 24 horas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una HTA secundaria. La hipoK+ sugiere HAP o RV. La clínica de debilidad y cefalea, más la hiponatremia marcada sugieren algo más un HAP que una HTA RV. Por ello, la respuesta es la D, aunque en realidad también se debería solicitar la A.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 59 1.03.1.009 · Hipertensión arterial de o

Hipertensión renovascular (yo vi 2 hiperaldosteronismos primarios, confirmo x2) habían 2, uno joven con muchos sintomas de hipokalemia (HAP)y la otra era adulto mayor con proteinuria (HTRV)? vs Hiperaldosteronismo primario

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Clase sobre diagnóstico, objetivos y pilares del tratamiento de la hipertensión arterial. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 82 1.03.1.009 · Hipertensión arterial de o

Paciente con HTA de difícil control, cefalea, palpitaciones y lesión suprarrenal derecha de 5 cm en TAC. ¿Diagnóstico más probable?

A) Adenoma suprarrenal productor de aldosterona
B) Carcinoma suprarrenal
C) Feocromocitoma
D) Quiste suprarrenal simple
E) Hiperplasia suprarrenal nodular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Feocromocitoma** (opción **C**). Feocromocitoma. Clase sobre diagnóstico, objetivos y pilares del tratamiento de la hipertensión arterial. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 171 1.03.1.012 · Hipogonadismo masculino

Un paciente de 32 años consulta por un cuadro de disfunción sexual asociado a disminución del vello facial. Al examen físico presenta disminución del vello corporal y disminución del tamaño testicular bilateral. ¿Cuál es el estudio más adecuado para proseguir el enfrentamiento de este paciente?

A) Prolactina
B) Testosterona y LH
C) Espermiograma y FSH
D) Ecografía testicular
E) HCG y estradiol

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un hipogonadismo clínico (disminuición del vello corporal, astenia y disfunción sexual: impotencia y disminución del deseo sexual), que se estudia con gonadotropinas (LH) y hormonas sexuales (testosterona en el hombre).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 83 1.03.1.012 · Hipogonadismo masculino

Hombre de 38 años con disminución de la libido, disfunción eréctil, fatiga y ginecomastia bilateral. Testículos de tamaño normal. ¿Cuál es el estudio de elección inicial?

A) Testosterona total sérica matinal
B) Ecografía testicular
C) Espermograma
D) FSH y LH
E) Prolactina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hipogonadismo masculino: el estudio inicial es testosterona total sérica en la mañana (máxima entre 8-10 AM). Si está baja, se complementa con LH/FSH para clasificar en primario o secundario.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 145 1.03.1.012 · Hipogonadismo masculino

Un paciente de 35 años, padre de tres hijos consulta por disfunción eréctil progre- siva que inició hace 3 meses. Su examen físico no muestra alteraciones, y su examen ge- nital y testicular resulta normal. Se solicitan exámenes que muestran testosterona de 190 ng/dL (valor normal: 280-1100ng/dL) y LH de 1,8 UI/L (valor normal: 1,5-20 UI/L). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?

A) Espermiograma
B) Ecografía testicular
C) Niveles plasmáticos de FSH
D) Resonancia magnética de hipófisis
E) Niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Resonancia magnética de hipófisis). Tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico, por tanto probablemente es hipota- lámico o hipofisiario.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 50 1.03.1.012 · Hipogonadismo masculino

Un paciente de 35 años, desde hace un año, presenta debilidad muscular, disminución de la libido e impotencia sexual progresiva. Se realizan exámenes, que muestran prolactina normal, niveles de LH: 1,6 UI/L (valor normal: 1,8 a 8,6 UI/L) y de testosterona: 160 ng/dl (valor normal: 270 a 1.070 ng/dl). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Ecografía testicular
B) Niveles plasmáticos de estradiol
C) Niveles de FSH
D) Solicitar niveles de testosterona libre
E) Resonancia magnética de hipófisis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un hipogonadismo (testosterona baja) hipogonadotrópico (LH baja), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria ("el hipo hipo es hipo hipo"). Se estudia con RMN de hipófisis. Vale la pena mencionar que, si la LH hubiese estado normal, en la zona "baja" del rango normal, igualmente sería un hipogonadismo hipogonadotrópico.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 149 1.03.1.003 · Hipertiroidismo

Mujer de 35 años con exoftalmo bilateral, palpitaciones, pérdida de peso y temblor fino en manos. TSH suprimida, T4 libre elevada. Bocio difuso. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Enfermedad de Graves-Basedow
B) Tiroiditis de Hashimoto
C) Bocio multinodular tóxico
D) Adenoma tóxico de tiroides
E) Tiroiditis subaguda de De Quervain

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hipertiroidismo + exoftalmo (oftalmopatía de Graves) + bocio difuso en mujer joven = enfermedad de Graves-Basedow (autoinmune, anticuerpos anti-TSH-R). El exoftalmo es patognomónico.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 145 1.03.1.003 · Hipertiroidismo

Era una clínica de ojo rojo, pero con temblor en las manos y baja de peso, al examen físico se observa retracción palpebral: a. TSH y T4 libre

A) Accidente cerebrovascular
B) Epilepsia
C) Esclerosis múltiple
D) Enfermedad de Parkinson
E) Migraña

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Accidente cerebrovascular). Los trastornos ansiosos incluyen el trastorno de pánico (o angustia), el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia social, las fobias simples, el TOC, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el estrés agudo y el trastorno adaptativo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 35 1.03.1.003 · Hipertiroidismo

Una paciente presenta un cuadro de 2 meses de evolución de sensación de calor mayor al habitual y sudoración. Se palpa su tiroides de tamaño normal y no presenta exoftalmo. Se solicitan pruebas tiroideas que demuestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 3,9 ng/ml. ¿Cuál es el examen de elección para determinar el diagnóstico etiológico?

A) Captación de yodo 131
B) Ecografía de tiroides
C) Punción aspirativa con aguja fina de tiroides
D) Cintigrafía tiroidea
E) Anticuerpos antitiroglobulina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cintigrafía tiroidea** (opción **D**). El hipertiroidismo se estudia con cintigrafía con I131 para determinar su etiología.. Los trastornos ansiosos incluyen el trastorno de pánico (o angustia), el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia social, las fobias simples, el TOC, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el estrés agudo y el trastorno adaptativo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 20 1.03.2.003 · Insuficiencia suprarrenal

Un paciente tiene diarrea de 3 días de evolución, asociada a malestar general marcado y vómitos alimentarios, con deterioro del estado general. Al examen físico se observa deshidratado, con FC: 110 x', PA: 70/40 mmHg, abdomen doloroso, sin irritación peritoneal. Se solicitan exámenes, entre los que destacan Na+: 126 mEq/L, K+: 4,7 mEq/L, glicemia: 58 mg/dl, PCR: 4,0, blancos: 12.000 por mm3, creatinina 2,3 mg/dl. Se administran 3 litros de suero fisiológico, sin lograr estabilizar al paciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Insuficiencia renal aguda
B) Shigelosis
C) Peritonitis aguda
D) Insuficiencia suprarrenal aguda
E) Accidente vascular hemorrágico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una crisis suprarrenal clásica: shock refractario, hiponatremia, hipoglicemia e hiperkalemia (el K+ está normal en este caso, pero en el límite alto). Sin embargo, también tiene una insuficiencia renal aguda (creatinina elevada), pero el diagnóstico más importante es la insuficiencia suprarrenal.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 110 1.03.2.005 · Tetania

Paciente con tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, presenta debilidad, parestesias y signo de Chvostek positivo. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Calcitriol oral más calcio oral
B) Gluconato de calcio endovenoso
C) Carbonato de calcio 1 g oral
D) PTH recombinante subcutáneo
E) Terlipresina endovenosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Gluconato de calcio endovenoso** (opción **B**). Gluconato de calcio endovenoso. Sin tratamiento evoluciona a cretinismo (déficit cognitivo irreversible). De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 25 1.03.2.005 · Tetania

Un paciente, con antecedente de tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, calcio y vitamina D, por vía oral, presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante. Evoluciona con astenia, marcada debilidad, dolor en las extremidades inferiores y calambres. Al examen físico tiene reflejos osteotendíneos vivos y signo de Chvostek positivo. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Suero fisiológico endovenoso
B) Gluconato de calcio endovenoso
C) Suero glucosado con potasio endovenoso
D) Suero Ringer endovenoso
E) Hidrocortisona endovenosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Gluconato de calcio endovenoso** (opción **B**). Tiene una hipocalcemia aguda grave clínica. Se debe tratar con gluconato de calcio urgente.. Sin tratamiento evoluciona a cretinismo (déficit cognitivo irreversible). De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 82 1.03.2.005 · Tetania

Una mujer de 29 años, con antecedente de tiroidectomía por cáncer de tiroides hace 5 meses, consulta por síntomas de una semana de evolución, consistentes en astenia, nerviosismo y palpitaciones, que han ido en aumento. Además, el día de hoy presentó convulsiones en una oportunidad, por lo que fue traída al Servicio de Urgencia. Al examen físico está en Glasgow 15, sin convulsiones actuales ni focalidad neurológica. Se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan glicemia: 120 mg/dl, potasemia: 4,0 mEq/l, natremia: 144 mEq/L, calcemia 6,3 mg/dl, fósforo: 5,5 mg/dl, albúmina: 3,9 g/dl y hematocrito: 48%. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada en esta paciente?

A) Administrar suero fisiológico
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Administrar calcio endovenoso
D) Administrar lorazepam endovenoso
E) Administrar calcitonina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hipocalcemia Post Tiroidectomía: El cuadro clínico sugiere hipocalcemia por hipoparatiroidismo post tiroidectomía, ya sea por extirpación o isquemia de las glándulas paratiroides. La calcemia baja confirma el diagnóstico. El tratamiento es con gluconato de calcio endovenoso 1g..

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 102 1.03.2.005 · Tetania

Una paciente, con antecedente de tiroidectomía total por cáncer de tiroides, con hipoparatiroidismo postquirúrgico, en tratamiento con levotiroxina 100 ug al día y con calcio 450 mg más vitamina D3 175 UI cada 8 horas, presenta diarrea acuosa, desde hace 4 días, a lo que se ha agregado astenia y debilidad, . Al examen físico se constatan signos vitales dentro del rango normal, examen cardiopulmonar normal, examen abdominal con abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, examen neurológico con signo de Chvostek y debilidad de las 4 extremidades, con reflejos osteotendíneos claros. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar calcio intravenoso
B) Aumentar la dosis de levotiroxina
C) Administrar suero fisiológico intravenoso
D) Administrar suero Ringer lactato intravenoso
E) Administrar bicarbonato de sodio endovenoso

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Administrar suero fisiológico intravenoso** (opción **C**). Sin tratamiento evoluciona a cretinismo (déficit cognitivo irreversible). De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 30 1.03.2.002 · Mixedema

Una paciente de 46 años, con antecedentes de anemia perniciosa y vi`ligo, es traída al servicio de urgencia por un cuadro de malestar general y desorientación. Sus familiaees relatan que ha presentado compromiso del estado general y astenia de 3 semanas de evolución, asociando recientemente a somnolencia y desorientación. Al examen Fsico está en sopor superficial y sus signos vitales muestran presión arterial: 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 62 lpm, temperatura: 36 °C. En el examen segmentario se obje8va lengua de gran tamaño y edema de extremidades inferiores. Al examen neurológico está soporosa, no 8ene focalidad neurológica y se observa enlentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendíneos. Los exámenes de laboratorio muestran sodio: 130 mEq/L, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 31%, VCM 102 fL, glóbulos blancos: 5.200/mm³ y plaquetas: 180.000/mm³. Se solicita TAC de cerebro, que no muestra alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Suero hipertónico endovenoso
B) Suero fisiológico endovenoso
C) Levo2roxina endovenosa
D) Cor2coides endovenosos
E) An2bió2cos endovenosos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un coma mixedematoso, en contexto de una GroidiGs autoinmune (reforzada por el viVligo y la anemia perniciosa, que son autoinmunes). La primera medida es dar corticoides EV, seguidos de la levoGroxina EV. Si se da directamente la levoGroxina existe riesgo de producir una insuficiencia suprarrenal aguda.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 153 1.03.2.002 · Mixedema

Paciente con piel seca, bradicardia, hipotensión, compromiso de conciencia, TSH 100 y T4 libre muy baja. ¿Diagnóstico?

A) Coma mixedematoso
B) Hipotiroidismo subclínico severo
C) Insuficiencia suprarrenal aguda
D) Encefalopatía hipoglucémica
E) Hipotiroidismo primario descompensado

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Coma mixedematoso** (opción **A**). Coma mixedematoso. El hipotiroidismo se presenta con astenia, adinamia, intolerancia al frío, constipación, piel seca, bradipsiquia, caída de la cola de las cejas, bradicardia e hipotermia en casos severos, hiporreflexia y alteraciones de laboratorio como anemia macrocítica, hiponatremia con VEC normal, hiperbilirrubinemia indirecta, dislipidemia (hipercolesterolemia) y aumento de CK. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 6 1.03.2.002 · Mixedema

Un paciente de 54 años, con antecedente de diabetes mellitus en tratamiento hipoglicemiante oral, hipertensión arterial e hipotiroidismo, suspende sus medicamentos hace 3 meses. Desde hace 2 semanas comienza con malestar general, asociado a letargo y dificultades en sus actividades de la vida diaria, agregándose compromiso de conciencia, por lo que es llevada a la urgencia. Al examen físico tiene facies edematosa, está hiporreactiva, con temperatura 35,1°C, pulso regular a 50x, presión arterial de 150/100 mHg, arreflexia generalizada y examen cardiopulmonar con ritmo regular en dos tiempos, sin soplo y murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos. Sus exámenes de laboratorio muestran glicemia: 270 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl, sodio plasmático: 129 mEq/L, potasio: 4,7 mEq/L, lo siguiente T4 libre: 0,1 ng/dl, TSH: 100 U/L, hemograma con hematocrito: 36%, hemoglobina: 12 g/dl, blancos: 7.000 por mm3 y plaquetas: 150.000 por mm3, CK: 390 UI/L (VN: 30 a 290) y CK-mb: 30 (VN: 0-25). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cetoacidosis diabética
B) Síndrome hiperglicémico hiperosmolar no acidótico
C) Infarto agudo al miocardio
D) Coma mixedematoso
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Cetoacidosis diabética** (opción **A**). El hipotiroidismo se presenta con astenia, adinamia, intolerancia al frío, constipación, piel seca, bradipsiquia, caída de la cola de las cejas, bradicardia e hipotermia en casos severos, hiporreflexia y alteraciones de laboratorio como anemia macrocítica, hiponatremia con VEC normal, hiperbilirrubinemia indirecta, dislipidemia (hipercolesterolemia) y aumento de CK. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 79 1.03.2.004 · Hipercalcemia aguda

Hombre de 55 años con hipercalcemia severa (Ca 13.5 mg/dL), náuseas, poliuria, confusión y deshidratación. PTH elevada. ¿Cuál es el tratamiento inicial de urgencia?

A) Resonancia magnética
B) Cintigrafía con sestamibi (localización de adenoma paratiroideo)
C) Hidratación EV con solución salina 0.9%
D) Paratiroidectomía de urgencia
E) Carbonato de calcio oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hipercalcemia sintomática/severa (Ca >12 mg/dL con síntomas): tratamiento de urgencia = hidratación EV agresiva con SF 0.9% (200-300 mL/h) para promover calciuria. Luego agregar bifosfonatos (zoledronato) o calcitonina. La cintigrafía es para planificación quirúrgica electiva, no urgente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 123 1.03.2.004 · Hipercalcemia aguda

Un paciente de 76 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, presenta un cuadro de 2 días de evolución de debilidad y malestar general, al que se agrega obnubilación de conciencia y tendencia al sopor. Al examen físico se aprecia desorientado, con sopor profundo, sin focalidad neurológica, tiene FC: 80x', PA: 150/100 mmHg y FR: 16x'. El examen torácico y abdominal no aporta mayor información. Se solicitan electrolitos plasmáticos que muestran sodio: 148 mEq/L, potasio: 5 mEq/L, calcio: 14,8 mg/dl y otros exámenes de sangre que muestran creatinina: 1,4 mg/dl, GOT: 50 UI/l, 2, APE: 200 ng/ml. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Administrar calcitonina endovenosa
B) Realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar ácido zolendrónico endovenoso
D) Administrar gluconato de calcio endovenoso
E) Administrar suero fisiológico endovenoso

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Administrar suero fisiológico endovenoso** (opción **E**). Tratamiento ordenado: 1° soporte, 2° corticoides EV (hidrocortisona), 3° levotiroxina EV (carga 400 µg), 4° T3 EV. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 33 1.03.4.004 · T4 libre

Una paciente de 25 años acude a chequeo médico. Como antecedente, usa suplementos de vitamina D y an8concep8vos orales. Los exámenes de laboratorio muestran T4 total de 16 ng/mL (valor normal 5 a 12) y TSH de 0,9 mU/L (valor normal 0,5 a 5). El examen Fsico es normal. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio?

A) An2cuerpos an2-receptor de TSH
B) Cin2gra:a 2roidea
C) Triyodo2ronina (T3)
D) T4 libre
E) Tiroglobulina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por regla general basta con la TSH como screening, en pacientes asintomáticos, por lo que no estaba indicado solicitar T4; al estar normal la TSH, la conducta más adecuada es simplemente observar (y disculparse por haber pedido exámenes de más). En el embarazo, uso de ACO y uso de andrógenos se eleva la TBG (globulina ligante de Groxina), por lo que la T4 total está falsamente elevada, siendo únicamente úGl la T4 libre. Lo mismo ocurre en el síndrome nefrótico y el daño hepático en que la TBG disminuye y la T4 total resulta falsamente baja. InsisGmos en que bastaba con la TSH.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 45 1.03.1.023 · Ginecomastia

Adolescente masculino de 14 años con aumento bilateral del tejido mamario subareolar, sensible al tacto, sin secreción. Sin medicamentos. Desarrollo puberal Tanner 3. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta?

A) Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar
B) Cáncer de mama masculino; biopsia urgente
C) Hiperprolactinemia; solicitar prolactina
D) Hipogonadismo; solicitar testosterona
E) Tumor testicular; solicitar ecografía testicular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ginecomastia bilateral en adolescente Tanner 3 sin medicamentos ni masa firme = ginecomastia puberal fisiológica. Ocurre en 50-70% de los púberes. Regresa espontáneamente en 1-2 años.

HEMATOLOGÍA & HEMOSTASIA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 08

84 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

29 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.08.1.001	Anemia de las enfermedades crónicas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · 8.1 (Pág. 5)
1.08.1.002	Anemia ferropénica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 08 · 8.2 (Pág. 7)
1.08.1.003	Anemia hemolítica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 08 · 8.7 (Pág. 26)
1.08.1.004	Anemia megaloblástica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 08 · 8.6 (Pág. 22)
1.08.1.006	Coagulopatías congénitas (hemofilias, von Willebrand)	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 08 · 8.13 (Pág. 45)
1.08.1.007	Disproteinemias (gammapatías M)	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 08 · 8.19 (Pág. 66)
1.08.1.009	Leucemias agudas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 08 · 8.16 (Pág. 56)
1.08.1.010	Leucemias crónicas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 08 · 8.17 (Pág. 60)
1.08.1.011	Linfomas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 08 · 8.18 (Pág. 62)
1.08.1.012	Púrpuras trombopénicos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 08 · 8.12 (Pág. 41)
1.08.1.018	Síndromes mieloproliferativos crónicos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · 8.20 (Pág. 68)
1.08.1.019	Trombofilias	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 08 · 8.23 (Pág. 79)
1.08.2.001	Coagulación intravascular diseminada	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · 8.15 (Pág. 51)
1.08.2.002	Coagulopatía adquirida	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.004	Hipercalcemia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.2.005	Lisis tumoral aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 08 · 8.22 (Pág. 77)
1.08.2.006	Neutropenia febril	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 08 · 8.21 (Pág. 73)
1.08.2.008	Síndrome vena cava superior	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.3.002	Conceptos generales de etapificación, radioterapia y quimioterapia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.3.011	Transfusión y sus complicaciones	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.08.3.012	Tratamiento anticoagulante	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.4.003	Biopsia de médula ósea	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.4.004	Electroforesis de proteínas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.4.005	Estudio de coagulopatías	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.4.006	Estudio de trombofilia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.4.008	Hemograma	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.4.009	Mielograma	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.4.010	Pruebas de hemólisis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)
1.08.5.002	Biopsia ganglionar	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 08 · Hematología (Pág. 8)

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 117 1.08.3.002 · Conceptos generales de eta

Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH de varios años, consulta por una lesión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 3 cm de diámetro, bordes cartográficos y que se introduce por el orificio anal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sífilis
B) Enfermedad de Cröhn
C) Carcinoma epidermoide
D) Melanoma
E) Linfogranuloma venéreo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece un cáncer de recto, que es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos y con virus papiloma humano (también de transmisión sexual).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 4 1.08.3.002 · Conceptos generales de eta

Una paciente de 60 años, es diagnosticada de cistoadenocarcinoma seroso de ovario el cual presenta diseminación difusa en peritoneo, por lo cual no es operable. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Cuidados paliativos
B) Radioterapia
C) Hormonoterapia
D) Quimioterapia
E) Inmunoterapia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Quimioterapia** (opción **D**). El Cáncer de ovario metastizado se trata con QT. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 111 1.08.3.002 · Conceptos generales de eta

Un adolescente, con diagnóstico de linfoma de Hodgkin, se realiza un ciclo de quimioterapia El diagnóstico más probable es:

A) Reacción adversa a medicamentos
B) Infiltración cutánea por linfoma
C) Prurito paraneoplásico
D) Mononucleosis infecciosa
E) Meningococcemia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El exantema macular eritematoso es la reacción adversa a medicamentos más frecuente. Las otras opciones no pueden ser.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 84 1.08.3.002 · Conceptos generales de eta

Mujer de 55 años con antecedente de cáncer de mama tratado hace 3 años, en seguimiento. Mamografía: BIRADS 4 en mama derecha y BIRADS 0 en mama izquierda. ¿Cuál es la conducta?

A) Biopsia de la lesión BIRADS 4 y completar estudio de mama izquierda
B) Solo observar en 6 meses
C) RMN mamaria bilateral
D) PET-CT para etapificación
E) Mastectomía bilateral profiláctica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
BIRADS 4 = sospechosa, requiere biopsia. BIRADS 0 = evaluación incompleta, requiere imágenes adicionales. Ambas conductas deben realizarse en forma paralela.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 119 1.08.3.002 · Conceptos generales de eta

Paciente con eritema y úlceras en areola mamaria de 4 meses de evolución. ¿Diagnóstico más probable?

A) Eczema atópico del pezón
B) Dermatitis de contacto
C) Carcinoma inflamatorio de mama
D) Enfermedad de Paget del pezón
E) Psoriasis invertida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Paget del pezón** (opción **D**). Enfermedad de Paget del pezón. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 117 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Un paciente de 73 años presenta astenia y disnea de esfuerzos importante, asociada a gran palidez de piel y mucosas. Refiere, también, parestesias en las 4 extremidades. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina: 6 mg/dl, VCM: 126 fl, glóbulos blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 105.000 por mm3 y 2 eritroblastos / 100 leucocitos. Se solicitan, además, LDH: 1.800 UI/L y bilirrubina: 5 mg/dl, de predominio indirecto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Mielodisplasia
B) Aplasia medular
C) Anemia por déficit de vitamina B12
D) Síndrome leucoeritroblástico
E) Anemia hemolítica autoinmune

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por la afectación neurológica, como por la pancitopenia con VCM tan elevado, es una anemia perniciosa, por déficit de B12.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 18 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Una paciente de 29 años, sin antecedentes, consulta por disnea progresiva asociada a fatigabilidad. Al examen físico destaca mucosas pálidas, cardiopulmonar normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 8.3mg/dL, hematocrito 26%, VCM 110, reticulocitos 0.3%, leucocitos 8.500/mm3 y plaquetas 200.000/mm3. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Anemia falciforme
B) Anemia perniciosa
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por enfermedades crónicas
E) Anemia por déficit de vitamina B6

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una anemia con VCM 110, es decir megaloblástica, por eso es por déficit de B12, causada en primer lugar por la anemia perniciosa. El déficit de folatos también podría ser una alternativa aceptable, pero los folatos son B9.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 104 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Adulto mayor con astenia, anemia, trombocitopenia, leucopenia, LDH elevada y VCM 123. ¿Diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Síndrome mielodisplásico
C) Anemia aplásica
D) Anemia megaloblástica
E) Linfoma no Hodgkin con compromiso medular

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Anemia megaloblástica** (opción **D**). Anemia megaloblástica. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 133 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Un paciente de 71 años consulta por malestar general y disnea progresiva, que actualmente es de pequeños esfuerzos. Al examen Fsico se observa pálido, con examen cardiopulmonar que muestra ritmo regular en dos 8empos, sin soplos, con frecuencia cardíaca 120 la8dos por minuto; y examen pulmonar que constata murmullo pulmonar simétrico sin otros ruidos. Se solicita hemograma que se informa con hematocrito: 16%, hemoglobina: 5,2 g/dL, VCM: 118 fL, CHCM: 40 g/dL, re8culocitos: 0,8%, plaquetas: 60.000/mm³ y glóbulos blancos: 3.300/mm³. Además, se solicita GOT: 52 U/L, bilirrubina total: 3,5 mg/dL y bilirrubina directa: 0,2 mg/dL. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Anemia megaloblás2ca
B) Anemia aplásica
C) Anemia hemolí2ca
D) Mielodisplasia
E) Mielop2sis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. El VCM tan elevado la sugiere fuertemente. Tanto anemia hemolítica como el déficit de B12 pueden tener VCM elevado, hiperbilirrubinemia indirecta y LDH elevada, pero los reGculocitos bajos son incompaGbles con una anemia hemolítica. Dada la gravedad que Gene, con hemoglobina bajo 7 g/dl, probablemente requiere de una transfusión de glóbulos rojos, además del tratamiento con vitamina B12 intramuscular. La causa más frecuente de déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa, de origen autoinmune, con anticuerpos contra las células parietales gástricas, que hace que no se produzca el "factor intrínseco", necesario para la absorción de B12. Por ello, se debe suplementar por vía intramuscular y no oral. En cambio, el déficit de B12 asociado a dietas vegetarianas y veganas sí se trata por vía oral.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 141 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Un paciente de 36 años, desde hace 4 años sigue dieta vegana estricta. Consulta por astenia, adinamia y palidez, a lo que se ha agregado disnea de grandes esfuerzos, que ha aumentado. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas, FC: 92x', PA: 100/70 mmHg, sin alteraciones del examen segmentario. Se solicita hemograma que muestra plaquetas: 200.000 por mm3, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 115 fl, HCM: 35 pg y reticulocitos 0,5%, con LDH: 450 UI/L. El examen más adecuado para proseguir el estudio es:

A) Nivel de vitamina B12
B) Mielograma
C) Biopsia de médula ósea
D) Perfil de fierro
E) Prueba de Coombs

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un déficit de B12, por baja ingesta (dieta vegana). La anemia macrocítica y megaloblástica (VCM > 108) la sugiere fuertemente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 138 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Un paciente de 80 años presenta astenia, bradipsiquia, confusión y disnea de mínimos esfuerzos. Al examen físico se aprecia pálido, con FC: 115x, PA: 120/80 mmHg. Se realiza un hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 5,9 g/dl, HCM: 34 pg, VCM: 117 fl, blancos: 3.100 por mm3, plaquetas: 57.000 por mm3 y, además, destaca LDH: 890 UI/L. EL diagnóstico más probable es:

A) Anemia aplástica
B) Anemia hemolítica
C) Anemia megalobástica
D) Mielodisplasia
E) Mieloma múltiple

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un clásico déficit de B12, con el compromiso neurológico y hematológico (pancitopenia, con VCM elevado). La LDH y la bilirrubina indirecta se elevan por la mielopoyesis inefectiva, al igual que en las anemias hemolíticas. Que el VCM sea mayor a 108 se conoce como anemia megaloblástica. Finalmente, la etiología más probable, en este caso, es una anemia perniciosa (enfermedad autoinmune contra las células parietales gástricas, que secretan el factor intrínseco, que permite la absorción de B12).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 10 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Un paciente de 60 años, gastrectomizado, presenta un cuadro de astenia, adinamia, asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad. Además ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. Al examen físico se aprecia disminución de los reflejos osteotendíneos, palidez y disminución de la sensibilidad de las Extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con Hemoglobina de 6,3 g/dl, VCM: 110 fl, plaquetas: 200.000 por mm3, blancos: 3.200 por mm3. La indicación más adecuada es:

A) Ácido fólico
B) Vitamina B12
C) Fierro
D) Biopsia de médula ósea
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Gastrectomía es la causa (falta factor intrínseco y no se absorve la B12). Tiene además la anemia megalobástica y la neuropatía, encefalopatía y probable degeneración combinada subaguda de la médula (todo causado por falta de B12).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 116 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Una paciente de 27 años, vegana estricta, con antecedente de cirugía bariátrica, presenta astenia y disnea de esfuerzos, asociado a palidez, por lo que se solicita un hemograma, con hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,1 g/dl, VCM: 122 fl, blancos: 4.100 por mm3 y plaquetas: 150.000 por mm3. ¿El déficit de qué elemento puede explicar los síntomas y hallazgos de laboratorio?

A) Hierro
B) Folatos
C) Zink
D) Vitamina B12
E) Vitamina D

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por ser vegetariana, como por la cirugía bariátrica, como por el VCM mayor a 108, es un défict de B12.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 104 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Una paciente de 64 años, con antecedente de by-pass gástrico, por obesidad mórbida, presenta un cuadro de dificultad a la marcha, asociado a astenia y malestar general. En sus exámenes destaca anemia macrocítica, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, ferritina 56 ug/dl y saturación de transferrina de 18%. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este caso?

A) Fierro
B) Ácido fólico
C) Cianocobalamina
D) Zinc
E) Tiamina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un déficit de B12 o cianocobalamina, por el antecedente de cirugía gástrica y porque tiene una bicitopenia con macrocitosis.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 67 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Paciente masculino de 88 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución. Al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte ictérico en escleras. Hemograma: Hemoglobina 6,6 grs/dl; hematocrito: 17%; VCM : 117 fl; plaquetas: 110.000 por mm3; glóbulos blancos: 3.400 x mm3; fórmula diferencial: neutrófilos: 74 %, linfocitos: 20 %, eosinófilos: 5 % y baciliformes: 1 %. El examen para confirmar el diagnóstico es:

A) Mielograma
B) Citometría de flujo
C) Prueba de Coombs
D) Niveles de Eritropoyetina.
E) Niveles de vitamina B12 y Ácido fólico.

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Era una anemia perniciosa clásica, con la macrocitosis y pancitopenia clásicas. Se estudia con B12 (cianocobalamina) y B9 (folatos).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 173 · 1.08.1.004 · Anemia megaloblástica

Adulto mayor con alteraciones de memoria y VCM > 100

A) Déficit de vitamina B12
B) Ninguna de las anteriores es correcta
C) Todas las anteriores son correctas
D) No se dispone de información suficiente
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Déficit de vitamina B12). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ninguna de las anteriores es correcta, Todas las anteriores son correctas) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 21 · 1.08.1.003 · Anemia hemolítica

Un paciente de 29 años presenta ictericia, disnea y compromiso marcado del estado general. Su examen Fsico solo muestra ictericia de escleras y piel, sin alteraciones relevantes en el examen segmentario. Sus exámenes de laboratorio muestran hemograma con hematocrito: 12%, hemoglobina: 4,1 g/dL, plaquetas: 250.000/mm³, glóbulos blancos 7.800/mm³, VCM: 103 fL y CHCM: 32 pg; en el fro8s se observa presencia de microesferocitos. Las pruebas hepá8cas muestran GOT: 52 U/L, GPT: 56 U/L, bilirrubina total: 4,1 mg/dL, bilirrubina directa 0,5: mg/dL, GGT: 50 U/L, fosfatasas alcalinas: 211 U/L y LDH: 960 U/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hepa22s A
B) Anemia por déficit de vitamina B12
C) Hemólisis
D) Anemia aplásica
E) Mielodisplasia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una anemia hemolítica clásica, probablemente autoinmune (AHAI). Orientan la anemia aguda y severa, con hiperbilirrubinemia indirecta, elevación de LDH. El VCM se puede elevar, por aumento de los reGculocitos. Los microesferocitos se ven en la AHAI, por el daño que sufren los glóbulos; en cambio, la microesferocitosis familiar suele ser un cuadro crónico, menos grave, con esplenomegalia y exacerbación durante los cuadros agudos. La prueba de Coombs directo está positiva en la AHAI y negativa en la mayoría de las otras causas de hemólisis.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 87 · 1.08.1.003 · Anemia hemolítica

Un paciente de 46 años, sin antecedentes, cursa con cuadro de disnea y palidez desde hace 2 semanas, asociado a coluria e ictericia. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas y se palpa esplenomegalia, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

A) Haptoglobina
B) LDH
C) Coombs
D) Hemograma con reticulocitos
E) Bilirrubina total e indirecta

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Parece una anemia hemolítica. Si bien suelen no tener coluria (ya que la Bili es indirecta), puede que sea hemoglobinuria (también oscurece la orina). Se debe empezar con el hemograma y reticulocitos. Luego se pedirá el Coombs directo.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 7 · 1.08.2.006 · Neutropenia febril

Una paciente de 56 años tiene antecedentes de cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia cuyo último ciclo fue hace 9 días. Consulta porque ha presentado malestar general y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico, se confirma febril, con frecuencia cardíaca 95x', PA: 120/80, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Hemograma
B) Radiografía de tórax
C) Urocultivo
D) Ecografía abdominal
E) Mielograma

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Urocultivo** (opción **C**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Hemograma, Radiografía de tórax) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 61 · 1.08.2.006 · Neutropenia febril

Paciente con leucemia en quimioterapia. Recuento absoluto de neutrófilos: 400/mm³. Inicia fiebre 38.5°C. Inicia ATB de amplio espectro. A las 72 horas persiste febril sin foco identificado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar antifúngico empírico (anfotericina B liposomal o voriconazol)
B) Cambiar antibiótico a vancomicina
C) Realizar PET-CT para buscar foco
D) Suspender ATB y observar
E) Agregar metronidazol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Neutropenia febril que no responde a ATB de amplio espectro en 72-96h: agregar antifúngico empírico (aspergilosis invasiva o candidiasis). Guías IDSA recomiendan anfotericina liposomal o equinocandinas.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 164 · 1.08.2.006 · Neutropenia febril

Una niña de 7 años con antecedente de leucemia aguda en tratamiento con quimioterapia presenta fiebre de 24 horas de evolución hasta 38,7°C. Su última quimioterapia se realizó hace 10 días. Al examen físico está en buenas condiciones generales, sin alteraciones que identifiquen un foco infeccioso. Tiene una temperatura de 38,5°C y se solicita un hemograma que muestra 800 leucocitos por mm?, con un recuento absoluto de neutrófilos de 450 por mm?, 95.000 plaquetas por mm? y un hematocrito del 35%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar paracetamol por vía oral más reposo relativo y observación
B) Administrar ceftriaxona endovenosa durante la primera hora de atención
C) Realizar TAC de tórax y abdomen
D) Esperar el resultado del estudio etiológico antes de iniciar antibióticos
E) Administrar esquema de cefotaxima y anfotericina B por vía endovenosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de la Neutropenia Febril: La neutropenia febril es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato con antibióticos, idealmente dentro de los primeros 30 a 60 minutos del ingreso. El régimen de antibióticos debe cubrir Gram negativos y las guías internacionales recomiendan que se cubra también Pseudomonas aeruginosa, siendo cefepime o un carbapenémico las opciones preferidas. En Chile, si se trata de una neutropenia de bajo riesgo (clásico ejemplo los pacientes en quimioterapia con buen aspecto), se acepta tratarlo con cefalosporinas de tercera generación convencionales como la ceftriaxona o el cefotaximo. Los antifúngicos se consideran si hay sospecha de infección fúngica, falta de respuesta a los antibióticos, o fiebre prolongada.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 109 · 1.08.2.006 · Neutropenia febril

Una paciente de 55 años, en quimioterapia por leucemia mieloide aguda, inicia desde hace algunas horas fiebre alta, cefalea y dolor al movimiento ocular, refiere haber estado en contacto con su hijo que cursaba con cuadro respiratorio alto. Se realiza exámenes donde destaca hemoglobina 8.5 mg/dL, leucocitos 1.000/mm3 (10% neutrófilos 90% linfocitos) y plaquetas 80.000/mm3. La conducta más adecuada frente a esta paciente es:

A) Indicar manejo sintomático
B) Indicar Ceftazidima con amikacina endovenosas
C) Indicar anfotericina B endovenoso
D) Indicar oseltamivir endovenoso
E) Indicar aislamiento e iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una neutropenia febril. Se trata con doble cobertura para pseudomona. En los casos en que se sospeche stafilococo, además se deja cloxa y si lleva más de 10-14 días, se agrega cobertura para aspergillus.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 37 · 1.08.1.007 · Disproteinemias (gammapatí

Pregunta 37 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 64 años consulta por dolores óseos. Se realiza un hemograma que muestra hematocrito: 24%, con hemoglobina: 8g/dl, VC;: 85 fl, plaquetas: 180.000 por mm3 y blancos: 5.800 por mm3, con VHS: 90 mm/h. En los otros exámenes, destaca hipogamaglobulinemia y en el análisis de proteínas séricas se objetiva elevación monoclonal de proteínas, en la zona Kappa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Macroglobulinemia de Waldeström
B) Gamapatía monoclonal incierta
C) Mieloma múltiple
D) Amiloidosis
E) Enfermedad por cadenas pesadas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Mieloma múltiple** (opción **C**). Era un mieloma múltiple, por cadenas ligeras peak monoclonal Kappa .. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 145 · 1.08.1.007 · Disproteinemias (gammapatí

Un paciente de 65 años, con cuadro de compromiso del estado general de tres meses de evolución asociado a nicturia y en las últimas semanas dolor lumbar. Al examen físico destaca paciente enflaquecido, piel seca y mucosas pálidas. Se solicitan exámenes de orina que muestra proteinuria ++, urocultivo negativo, 2-3 glóbulos rojos por campo, creatinina 1,8mg/dL y antígeno prostático de 5,5 (VN <4). Además se realiza ecografía renal que muestra dos quistes renales en lado derecho, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Mieloma múltiple
B) Cáncer prostático metastásico
C) Cáncer renal metastásico
D) Espondilodiscitis crónica
E) Espondilolistesis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Mieloma múltiple** (opción **A**). Anemia, insuficiencia renal, dolores óseos. Es un mieloma.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 12 · 1.08.1.010 · Leucemias crónicas

Un paciente de 81 años, en espera de una cirugía de cataratas, se realiza un hemograma, como parte de los exámenes preoperatorios, que muestra 140.000 blancos, con predominio de linfocitos, de aspecto redondo, con citoplasma escaso, cromatina heterogénea y sombras de Gumprecht, además tiene hemoglobina de 13,1 g/dl y 180.000 plaquetas por mm3. Al examen físico se palpa una adenopatía cervical de 3 cm, indolora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Mielodisplasia
C) Leucemia mieloide crónica
D) Linfoma
E) Leucemia linfática crónica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Leucemia linfática crónica** (opción **E**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 164 · 1.08.1.010 · Leucemias crónicas

Una paciente de 83 años se realiza exámenes preoperatorios, por una cirugía de cataratas, entre los que destaca un hemograma con 86.000 glóbulos blancos por mm3, hematocrito: 32%, hemoglobina: 11 g/dl, plaquetas: 123.000 por mm3. La fórmula diferencial muestra 86% de linfocitos, con aumento de citoplasma y sombras de Gumprecht en el frotis. Al examen físico se palpan múltiples adenopatías gomosas, generalizadas, de 2 a 3 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

A) Leucemia mieloide crónica en crisis blástica
B) Linfoma
C) Leucemia linfática crónica clásica
D) Leucemia mieloide crónica estable
E) Leucemia de células velludas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una LLC clásica: adulto mayor con leucocitosis, linfocitosis y suele tener anemia y trombopenia. Las sombras de Gumprecht también son características (no confundir con los bastones de Auer de la LMA). Su clínica suele ser ausente o inespecífica y al examen físico suelen haber adenopatías (también en la LLA y en los linfomas). Los linfomas suelen tener hemograma normal. La LMC tiene leucocitosis de predominio neutrofílico, con desviación izquierda y con trombocitosis y elevación de los eosinófilos, basófilos y monocitos; pero, luego se va "agudizando", a medida que avanza la enfermedad y va aumentando el número de blastos y disminuyendo el número de plaquetas y glóbulos rojos.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 108 · 1.08.1.010 · Leucemias crónicas

Un paciente de 65 años, diabético, presenta un cuadro de astenia y sensación febril de 4 semanas de evolución, asociado a baja de peso de 3 kilogramos, no explicado. Además, refiere dolor abdominal epigástrico y en el hipocondrio izquierdo. Al examen físico tiene ligera palidez de mucosas y se palpa el bazo por 13 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, VCM: 90 fl, blancos: 65.000 por mm3, con 15% de juveniles, 20% mielocitos, 13% promielocitos y 5% de blastos, con plaquetas: 450.000 por mm3. El diagnóstico más probable es:

A) Leucemia mieloide aguda
B) Leucemia linfática crónica
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mielofibrosis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una LMC clásica, con la marcada leucocitosis y desviación izquierda, sin hiato leucémico. Los blastos en 5% están en el límite respecto a una leucemia aguda, sin embargo, las plaquetas en el límite alto del rango normal orientan a LMC por sobre LMA. Ambas cursan con esplenomegalia. La anemia orienta más a LMA, pero también se puede ver en la LMC más avanzada. Finalmente, la LMC no tiene hiato leucémico, como en este caso.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 53 1.08.1.010 · Leucemias crónicas

Un paciente consulta por fiebre, malestar general y astenia. Al examen físico tiene esplenomegalia de 15 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que muestra plaquetas: 450.000 por mm3, hematocrito: 39%, glóbulos blancos: 60.000 por mm3, con 20% de juveniles, 15% de mielocitos, 20% de baciliformes y 5% de blastos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leucemia mieloide aguda
B) Leucemia mieloide crónica
C) Mielofibrosis
D) Leucemia linfática aguda
E) Leucemia linfática crónica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Leucemia mieloide crónica** (opción **B**). Es una LMC clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 66 1.08.2.008 · Síndrome vena cava superio

Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a confusión mental y tos. Al examen físico está desorientado, tiene eritema y cianosis de la cara y se observa dilatación de las venas del cuello. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear de tórax
B) Administrar diuréticos por vía endovenosa
C) Realizar quimioterapia de urgencia
D) Realizar radioterapia de urgencia
E) Realizar broncoscopía de urgencia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome de vena cava superior: Caracterizado por obstrucción del flujo a través de la VCS con edema facial, distensión yugular, tos y disnea. En cáncer de células pequeñas, el tratamiento clásico es la radioterapia urgente (aunque actualmente se prefiere quimioterapia + stent).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 67 1.08.2.008 · Síndrome vena cava superio

Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a confusión mental y tos. Al examen físico está desorientado en tiempo y espacio, tiene eritema y cianosis de la cara y se observa dilatación de las venas del cuello. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear de tórax
B) Administrar diuréticos por vía endovenosa
C) Realizar quimioterapia de urgencia
D) Realizar radioterapia de urgencia
E) Realizar broncoscopía de urgencia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome de vena cava superior: El síndrome de vena cava superior se caracteriza por la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior, lo que produce una serie de síntomas como edema facial, distensión de las venas del cuello, tos y disnea. El diagnóstico es principalmente clínico, aunque se puede complementar con TAC de tórax. Las recomendaciones actuales sugieren el uso de corticoides endovenosos en los casos de linfoma (la segunda causa más frecuente de síndrome de vena cava superior, después del cáncer de pulmón de células pequeñas) más la colocación de un stent venoso o la realización de una trombectomía para desobstruir mecánicamente la vena cava superior si hay un trombo presente. Tras la estabilización del paciente, se debe iniciar un tratamiento oncológico urgente basado en la biopsia del tumor. En el pasado, el tratamiento de elección era la radioterapia urgente (probablemente es lo que evaluaba esta pregunta), pero actualmente no se recomienda.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 92 1.08.2.008 · Síndrome vena cava superio

Un paciente de 35 años, consulta por un cuadro de 1 semana de malestar general, sensación de edema de la cara en la mañana y tos que ha ido aumentando. Al examen físico se constata una adenopatía cervical, yugulares ingurgitadas y edema facial y de las manos. Además tiene signos de derrame pleural bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis
B) Hipotiroidismo
C) Taponamiento cardíaco
D) Mononucleosis infecciosa
E) Síndrome de vena cava superior

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome de VCI clásico, probablemente secundario a un linfoma, dada la edad y las adenopatías.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 13 1.08.2.008 · Síndrome vena cava superio

Un joven de 17 años presenta un cuadro de fiebre y baja de peso, con malestar general, de algunas semanas de evolución. Consulta ahora por un cuadro de rápida instalación de cefalea, tos, edema de extremidades superiores y de la cara, seguido de desorientación y sopor. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?

A) Radiografía de tórax
B) Ecocardiograma
C) TAC de tórax con contraste
D) Endoscopía digestiva alta
E) Resonancia magnética nuclear

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome de vena cava superior, probablemente secundaria a un linfoma. El diagnóstico es clínico (no aparece en las opciones). El TAC es la mejor imagen para ver las adenopatías mediastínicas que producen el cuadro.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 164 1.08.1.006 · Coagulopatías congénitas (

Paciente con epistaxis, equimosis, gingivorragias frecuentes, antecedente familiar de epistaxis y menorragias, TTPA levemente prolongado. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trombocitopenia inmune primaria (PTI)
B) Hemofilia A
C) Déficit de factor XI
D) Enfermedad de Von Willebrand
E) Coagulación intravascular diseminada (CID)

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Von Willebrand** (opción **D**). Enfermedad de Von Willebrand. Esta clase cubre la hemofilia de manera breve. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 130 1.08.1.006 · Coagulopatías congénitas (

Un paciente de 18 años presenta equimosis frecuente y tendencia a presentar petequias en las extremidades inferiores. Como antecedente, presentó hemorragia tardía, en relación a la extracción de un molar y hace algunos años sufrió un hematoma en el muslo izquierdo, en relación a un traumatismo, que requirió manejo hospitalizado. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con 160.000 plaquetas por mm3, sin alteraciones de la serie roja ni blanca, TTPA de 45 segundos y TP de 100%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Glanzmann
B) Enfermedad de von Willebrand
C) Déficit de factor VII
D) Hemofilia
E) Púrpura trombopénica inmune

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una EvW clásico (alteración de hemostasia primaria: petequias y alveolorragia), con plaquetas normales (es disfunción plaquetaria) y puede alargar levemente el TTPA. La hemofilia alarga el TTPA pero tendría muchos más síntomas y hematomas, además de hemartrosis y sin petequias.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 14 1.08.1.006 · Coagulopatías congénitas (

Un joven de 18 años presenta sangrado prolongado, luego de la extracción de un molar. Además refiere equimosis ante pequeños traumatismos y epistaxis frecuente. Hace unos años estuvo hospitalizado por un hematoma profundo del muslo derecho. Su hemograma es normal y su TTPA está levementa alargado, con protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Von Willebrand
B) Púrpura trombopénico inmune
C) Enfermedad de Glanzmann
D) Hemofilia
E) Factor V de Leiden

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy difícil, porque tanto la hemofilia como la EvW producen epistaxis, equimosis y alveolorragia (epistaxis y alveolorragia son más de EvW). El alargamiento leve del TTPA también puede verse en ambos, aunque la palabra “leve” orienta más a EvW. El hematoma profundo orienta más a hemofilia y es el dato más fuerte como para elegirla, pero la EvW puede tenr hematomas y tipo 3 se caracteriza por tenerlos. Un caso como este está límite entre ambas. La hemofilia probablemente sería más grave, con síntomas desde la infancia y con hemartrosis y más hematomas.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 22 1.08.1.006 · Coagulopatías congénitas (

Una paciente de 17 años, que desde los cinco años presenta epistaxis con frecuencia y equimosis ante pequeños traumatismos, desde los 14 años tiene su menarquia con sangrado menstrual abundantes. Se solicita hemograma que muestra hematocrito 45%, VCM: 90fl, leucocitos 6.000/mm3, plaquetas 250.000/mm3, TTPA normal, protrombinemia 85% y tiempo de sangría mayor a 8 minutos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir con el estudio en este caso?

A) Mielograma
B) Citometría de flujo para receptor de la glicoproteína IIb IIIa
C) Estudio de enfermedad de Von Willebrand
D) Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
E) Electroforesis de proteínas en sangre

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una alteración de la hemostasia primaria (sangramientos mucosos, alargamiento del tiempo de sangría), es decir, de las plaquetas. Por estar normal el número de plaquetas, es una disfunción plaquetaria. El curso crónico muestra una patología genética, de las que la más frecuente es la EvW. Solo si resultara normal, se buscarían otras como la enfermedad de Glanzmann, que altera la Gp Ib IIIa.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 119 1.08.1.006 · Coagulopatías congénitas (

Niño que consulta por sangrado post extracción dental (creo que tenía otros sangrados mucosos) con TTPA aumentado, plq normales, madre tenía reglas abundantes: a. Enfermedad de Von Willebrand (se había preguntado el mismo caso en otro Eunacom y esta era la respuesta) b. Hemofilia c. Déficit de Vitamina K Era hemofilia ??? - es una EVW EVW aumenta el ttpa si severa

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Control sano habitual). Esta clase cubre la hemofilia de manera breve. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 156 1.08.2.004 · Hipercalcemia

Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:

A) Calcitonina
B) Solución salina al 0,9%
C) Vitamina D
D) Bifosfonatos
E) Corticoides

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una hipercalcemia por el mieloma. La primera medida es el suero fisiológico. Luego los bifosfonatos, para evitar que recurra. Solo si no funciona se administra calcitonina. Los corticoides sirven en la hipercalcemia por cáncer hematológicos, pero no son lo más importante.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 105 1.08.2.004 · Hipercalcemia

Paciente con cáncer de próstata y calcio de 14 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Bifosfonatos endovenosos (ácido zoledrónico)
B) Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)
C) Calcitonina intranasal
D) Prednisona oral 40 mg/día
E) Diálisis de urgencia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva)** (opción **B**). Suero fisiológico endovenoso (hidratación agresiva). Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 67 1.08.2.004 · Hipercalcemia

Un paciente de 64 años, con antecedente de haber sido tratado por un mieloma, con buena respuesta, consulta ahora por cuadro de astenia, con constipación y aumento del volumen urinario, a lo que luego se le agrega desorientación. Al examen físico se aprecia soporoso, pálido. En sus exámenes presenta hematocrito 27%, con Hb: 9 g/dl, VHS: 93 mm/h, proteínas plasmáticas: 7,8 g/dl, albúmina: 3,7 g/dl, sodio: 140 mEq/L, potasio: 4,8 mEq/L, calcio: 14,3 mg/dl. En este momento debe recibir:

A) Calcitonina
B) Solución salina al 0,9%
C) Vitamina D
D) Bifosfonatos
E) Corticoides

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una hipercalcemia por el mieloma. La primera medida es el suero fisiológico. Luego los bifosfonatos, para evitar que recurra. Solo si no funciona se administra calcitonina. Los corticoides sirven en la hipercalcemia por cáncer hematológicos, pero no son lo más importante.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 106 1.08.1.011 · Linfomas

Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado a leve malestar general, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico, se palpan adenopatías submandibulares y cervicales bilaterales de consistencia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis ganglionar
B) Linfoma
C) Infección por VIH
D) Sarcoidosis
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Linfoma de Hodgkin: La historia clínica sugiere un linfoma, probablemente de Hodgkin, por la presencia de síntomas B (fiebre, sudoración nocturna, malestar) y la edad. El diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia ganglionar.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 107 1.08.1.011 · Linfomas

Una paciente de 20 años consulta por aumento de volumen en el cuello de 2 meses de evolución, asociado, en el último tiempo, a leve malestar general, fiebre ocasional y sudoración nocturna. Al examen físico, se palpan adenopatías submandibulares y cervicales bilaterales de consistencia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tuberculosis ganglionar
B) Linfoma
C) Infección por VIH
D) Sarcoidosis
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Linfoma de Hodgkin: La historia clínica sugiere un linfoma, probablemente un linfoma de Hodgkin, debido a la presencia de síntomas B y la edad. Sin embargo, estos síntomas no son específicos de este tipo de cáncer. El diagnóstico definitivo se realiza mediante una biopsia ganglionar excisional.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 4 1.08.1.011 · Linfomas

Una paciente de 22 años presenta un cuadro de fiebre nocturna, asociada a baja de peso de 3 meses de evolución y astenia. Además refiere aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia palidez de piel y mucosas y una masa de 6 cm de diámetro en la cara lateral derecha del cuello. En la radiografía de tórax, se constata ensanchamiento del mediastino. El diagnóstico más probable es:

A) Leucemia linfática crónica
B) Infección por VIH
C) Tuberculosis ganglionar
D) Linfoma de Hodgkin
E) Linfoma no Hodgkin

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En estricto rigor, es una mala pregunta, ya que puede ser cualquiera de los tipos de linfoma (adenopatías, síntomas B). Sin embargo, los síntomas B (sudoración, fiebre y baja de peso) y la edad orientan más a linfoma Hodgkin (clásico de adolescentes y adultos jóvenes) La palidez y otros signos de anemia son más frecuentes en las leucemias, pero el resto de la clínica sugiere linfoma.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 140 1.08.1.011 · Linfomas

Un paciente de 15 años consulta por tos de 7 días de evolución asociada a cefalea y malestar general, que en los úl8mos día ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas, dificultad respiratoria y edema de la cara. Al examen Fsico se observa agitado, con eritema facial, edema de párpados y lengua de mayor tamaño que lo normal. Se aprecian yugulares visibles en el cuello y se palpan adenopa`as cervicales múl8ples, de hasta 2 cm de diámetro. Se solicita radiograFa de tórax que muestra presencia de una masa medias`nica. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Linfoma de Hodgkin
B) Carcinoma broncogénico
C) Cáncer de 2roides
D) Tuberculosis
E) Timoma

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome de vena cava superior, cuyas causas más frecuentes son el cáncer de células pequeñas y el linfoma. Por la edad y las adenopaVas, lo más probable, por lejos es un linfoma de Hodgkin. Si hubiese sido un adulto mayor fumador, sería más probable el carcinoma broncogénico.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 102 1.08.1.011 · Linfomas

Un paciente de 55 años presenta un cuadro de 3 meses de evolución de astenia y baja de peso de 5 kg, a lo que se ha agregado sudoración en la noche y fiebre intermitente hasta 38,5 °C que ha manejado con paracetamol. Al examen Fsico está hemodinámicamente estable, con signos vitales dentro de rango normal, y se palpan adenopa`as cervicales de consistencia gomosa en ambos lados de la zona anterior del cuello. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 37%, hemoglobina: 12,2 g/dL, glóbulos blancos: 5.600/mm³ y plaquetas: 160.000/mm³. Se solicita radiograFa de tórax que muestra múl8ples adenopa`as medias`nicas y TAC de abdomen y pelvis que muestra presencia de múl8ples adenopa`as retroperitoneales. ¿Cuál es el examen de elección para determinar el diagnós8co en este caso?

A) Biopsia de médula ósea
B) Serología para virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y VIH
C) Biopsia aspira2va de la adenopaaa
D) Biopsia ganglionar excisional
E) Hemocul2vos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha diagnóstica es un linfoma, que se diagnostica por biopsia ganglionar, idealmente excisional. Por la edad, con probabilidad es no Hodgkin. El hemograma está normal (excepto por una mínima anemia).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 117 1.08.4.009 · Mielograma

Un hombre de 80 años, diabético, consulta por dolor intenso en la zona costal derecha, que aumenta con la palpación y movimientos. Al examen físico tiene dolor epicrítico al palpar la zona. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 27%, plaquetas: 103.000 por mm3, blancos: 5.000 por mm3, VHS: 90 mmHg. Además, trae creatininemia: 2,1 mg/dl, calcio: 10,8 mg/dl, proteínas: 9,1 g/dl y albúmina plasmática: 3,0 g/dl. La ecografía abdominal muestra riñones de tamaño normal. ¿Cuál es el examen de elección para la confirmación diagnóstica?

A) Beta2 microglobulina
B) Resonancia magnética de columna
C) Radiografía de parrilla costal
D) Mielograma
E) Biopsia renal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es un mieloma múltiple (se diagnostica con biopsia de médula ósea, aunque es suficiente el mielograma): anemia, disminución de las plaquetas, IRC, hipercalcemia, hiperproteinemia con hipoalbuminemia y el dolor óseo. Por si acaso, dolor epicrítico es lo mismo que dolor somático (ej. cuando alguien se quiebra un hueso), en contraposición al dolor visceral o neuropático.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 112 1.08.4.009 · Mielograma

Un paciente de 75 años presenta un cuadro de dolor lumbar de 3 meses de evolución, asociado a pérdida de peso y astenia. En sus exámenes tiene hemograma con hemoglobina: 9,2 g/dl, Plauqetas: 92.000 por mm3, blancos: 5000 por mm3, VHS:103 mm/h, creatinina: 1,7 mg/dl, albúmina: 3,2 g/dl, proteínas plasmáticas: 9,8 g/dl. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Radiografía de huesos largos
B) Radiografía de cráneo
C) Recuento de inmunoglobulinas
D) Mielograma
E) Calcemia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un mieloma, que se diagnostica con mielograma o biopsia de médula ósea (el mielograma equivale al frotis de médula ósea).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 24 1.08.4.009 · Mielograma

Un niño de 8 años presenta dolores óseos, asociados a malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño, por 3 cm bajo el reborde costal de consistencia indurada, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Cintigrafía ósea
B) Hemograma
C) Biopsia esplénica
D) Electroforesis de proteínas en sangre
E) Mielograma

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una leucemia aguda clásica. Probablemente LLA, por se niño. Si bien se inicia el estudio con un hemograma, la pregunta es el examen confirmatorio, es decir, el mielograma (frotis de la médula ósea) o la biopsia de médula ósea (se ve la arquitectura también).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 118 1.08.1.009 · Leucemias agudas

Paciente de 25 años, presenta desde hace 3 semanas compromiso del estado gene- ral, sensación febril cuantificada hasta 38°C, asociado a astenia y tendencia a presentar equimosis frente a pequeños traumatismos. Al examen físico se aprecia pálida, se palpa esplenomegalia y se observan abundantes petequias en abdomen y extremidades infe- riores asociadas a equimosis en extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probble?

A) Leucemia aguda
B) Mononucleosis infecciosa
C) Linfoma
D) Síndrome hemolítico uremico
E) Coagulación intravascular diseminada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Leucemia aguda** (opción **A**). Era una leucemia aguda clásica.. La vejiga neurogénica es la pérdida de la función vesical normal por denervación, lo que impide que la vejiga se contraiga adecuadamente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 67 1.08.1.009 · Leucemias agudas

Un paciente de 86 años acude a control por astenia y malestar general de 2 meses de evolución, asociado a bradipsiquia en el último tiempo. Al examen físico, se aprecia palidez de piel y mucosas y se constatan signos vitales con FC: 110x', PA: 126/76 mmHg, sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma, con hematocrito 16%, hemoglobina: 5,3 g/dl, VCM: 126 ft, glóbulos blancos: 3.300 por mm3, plaquetas: 108.000 por mm3, bilirrubina: 3,6 mg/dl, con fracción directa de 0,6 mg/dl, LDH: 1.012 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Mielodisplasia
B) Mieloma múltiple
C) Anemia hemolítica
D) Anemia megaloblástica
E) Leucemia mieloide aguda

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Leucemia mieloide aguda** (opción **E**). La vejiga neurogénica es la pérdida de la función vesical normal por denervación, lo que impide que la vejiga se contraiga adecuadamente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 154 1.08.1.009 · Leucemias agudas

Paciente femenina, de 17 años presenta astenia, decaimiento, dolores óseos y pérdida de peso, de 2 meses evolución. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías cervicales y axilares, con bazo palpable 3 cm debajo del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Linfoma de Hodgkin
B) Leucemia mieloide aguda
C) Leucemia linfática aguda
D) Síndrome mononucleósico
E) Leucemia linfática crónica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La clínica es de leucemia aguda. En la práctica es imposible diferenciar una leucemia mieloide aguda de una linfática aguda solo por la clínica, pero las adenopatías y la edad (joven) sugieren más una leucemia linfática aguda.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 134 1.08.1.009 · Leucemias agudas

Un paciente de 70 años, desde hace 2 semanas ha presentado marcado malestar general y astenia, notando aparición de equimosis en las piernas. En su examen físico, se aprecia pálido, con petequias generalizadas y equimosis. Además, se palpan adenopatías en cuello e ingle. Se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8,1 g/dl, hematocrito: 24%, glóbulos blancos: 45.000 por mm3, con 60% de blastos linfoides. Su otros exámenes muestran glicemia: 160 mg/dl, Na+: 136 mEq/L, K+: 6,3 mEq/L, ácido úrico: 12,2 mg/dl, fósforo: 7,1 mg/dl, creatinina: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Imipenem
B) Heparina
C) Hidrocortisona
D) Sulfonato de poliestireno
E) Quimioterapia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Quimioterapia** (opción **E**). El tratamiento más importante de la vejiga neurogénica es el autocateterismo limpio intermitente con sonda nelaton, que es limpio pero no estéril, e intermitente pero no permanente De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 54 1.08.1.019 · Trombofilias

Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 85 años, por un accidente vascular encefálico y su padre tuvo un infarto agudo al miocardio a los 60 años. En sus exámenes destacan plaquetas: 140.000 por mm3, TTPA prolongado y VDRL (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de antitrombina III
B) Déficit de factor VIII
C) Síndrome antifosfolípidos
D) Púrpura trombocitopénica trombótica
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una trombofilia (A y C son compatibles). El TTPA alargado y el VDRL reactivo orientan mucho a un síndrome antifosfolípidos. El déficit de facor VIII produce hemofilia, por lo que tiene hemorragias, al igual que la EvW.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 51 1.08.1.019 · Trombofilias

Un paciente de 32 años, presenta una trombosis venosa profunda femoropoplítea. Como antecedente, su abuelo falleció a los 80 años, por un accidente vascular encefálico y su padre falleció a los 60 años por un infarto agudo al miocardio. En sus exámenes destacan TTPA: 39 segundos (valor normal: 25 a 35) y VDRL (+). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de antitrombina III
B) Déficit de factor VIII
C) Síndrome antifosfolípidos
D) Sífilis secundaria
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome antifosfolípidos** (opción **C**). La clínica de TVP, más el TTPA alargado y el VDRL+ es clásico del SAF.. La trombosis venosa profunda (TVP) es una patología frecuente causada por la tríada de Virchow: hipercoagulabilidad, estasis venosa y daño endotelial. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 55 1.08.1.019 · Trombofilias

Un paciente de 18 años consulta por dolor y aumento de volumen en la pantorrilla izquierda, en relación a un pequeño traumatismo. Se solicita un estudio Doppler de las extremidades inferiores, que muestra alteraciones del drenaje venoso profundo de la zona. En sus exámenes, se constata hematocrito: 38%, hemoglobina: 12,8 g/dl, plaquetas: 145.000 por mm3, blancos: 8.000 por mm3, TTPA 54 segundos, protrombina: 85%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de antitrombina III
B) Hemofilia A
C) Trombofilia por anticoagulante lúpico
D) Hemofilia B
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trombofilia por anticoagulante lúpico** (opción **C**). Es otro síndrome antifosfolípidos, por la misma razón del TTPA alargado (mayor a 40).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 52 1.08.4.010 · Pruebas de hemólisis

Una mujer de 40 años consulta por astenia, asociada a adinamia y disnea de medianos esfuerzos progresivas, desde hace una semana. Al examen físico tiene palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 24%, hemoglobina: 8 mg/dl, VCM elevado; glóbulos blancos: 9.800 por mm3, plaquetas: 160.000 por mm3. El frotis sanguíneo demuestra macrocitosis y policromasia. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Prueba de Coombs
B) Niveles plasmáticos de B12
C) LDH y bilirrubina directa
D) Recuento de reticulocitos
E) Biopsia de médula ósea

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

C, D? Tiene clínica de una anemia, probablemente hemolítica. Al preguntarse el diagnóstico etiológico, probablemente la prueba de Coombs sea la respuesta correcta, ya que diagnostica la anemia hemolítica autoinmune. Sin embargo, los distractores son muy fuertes, ya que aún no hay claridad sobre la etiología de la anemia en sí y los reticulocitos, así como la LDH y bilirrubina indirecta ayudan al diagnóstico de la hemólisis. Es una mala pregunta en mi opinión.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 54 · 1.08.2.001 · Coagulación intravascular

Una mujer puérpera, preseenta hemorragia postparto importante. En sus exámenes destacan hemograma con hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,3 g/dl, glóbulos blancos: 8.000 por mm3, plaquetas: 80.000 y además tiene TTPA y TP alargados y fibrinógeno 90 mg/dl (VN: 200 a 400) ¿Cuál es la mejor indicación transfusional?

A) Crioprecipitado
B) Glóbulos rojos
C) Plaquetas
D) Sangre fresca
E) Plasma fresco congelado

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Plasma fresco congelado). Es una coagulación intravascular diseminada clásica.. Esta clase cubre la coagulación intravascular diseminada (CID), una complicación grave del paciente crítico y de las neoplasias. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 75 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

Niño de 6 años previamente sano, sin medicamentos, consulta por púrpura petequial generalizada de inicio súbito posterior a infección viral. Plaquetas: 10.000/mm³. Resto del hemograma normal. Sin adenopatías ni visceromegalias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
B) Púrpura trombótica trombocitopénica
C) Síndrome hemolítico urémico
D) Coagulación intravascular diseminada
E) Leucemia aguda linfoide

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

PTI: trombocitopenia aislada severa en niño sano post-viral, sin anemia hemolítica ni IRA (descarta SHU/PTT), sin blastos (descarta leucemia). El PTI pediátrico es autolimitado en el 80% en 6 meses. Tratamiento: observación si asintomático, IGIV o corticoides si hay sangrado.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 131 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

Paciente hospitalizado en anticoagulación con heparina no fraccionada. Exámenes: TP 14s (normal), TTPA 120s (normal 25-35s), plaquetas 45.000/mm³ (bajaron de 180.000 hace 5 días). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombocitopenia inducida por heparina (HIT) tipo II
B) CID
C) PTT
D) Trombocitopenia por sepsis
E) Efecto del anticoagulante sobre el conteo plaquetario

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Caída de plaquetas >50% a los 5-10 días de inicio de heparina = HIT tipo II (mediada por anticuerpos anti-PF4/heparina). Suspender heparina inmediatamente y cambiar a anticoagulación alternativa (argatrobán).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 121 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

Adulto con PTI sin sangrado grave, plaquetas en 5.000:

A) Corticoides 1mg/kg
B) Transfusión de plaquetas
C) Terapia biológica
D) Amoxicilina
E) Ibuprofeno

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Corticoides 1mg/kg). Esta clase introduce el concepto de púrpura en medicina. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Transfusión de plaquetas, Terapia biológica) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 107 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

48 horas y que ha evolucionado con deterioro del estado general y desorientación. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, presencia de múltiples petequias y algunas equimosis en las extremidades inferiores, con edema bimaleolar. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 Ul/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 29%, plaquetas: 70.000/mma3, blancos: 8.000/mma3, frotis con esquistocitos, poiquilocitos y anisocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénica inmune
B) Síndrome de Evans
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Púrpura trombocitopénico trombótico
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una PTT clásica, con la trombopenia, anemia hemolítica, falla renal (igual al SHU) y afectación neurológica tanto central como periférica.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 131 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

Un paciente de 24 años presenta un cuadro de cefalea y desorientación, asociado a malestar general e ictericia. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, PA: 160/100 mmHg, se palpa edema de ambas extremidades inferiores. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina total: 12 mg/dl, LDH: 2.100 UI/L, creatinina: 3,5 mg/dl, hemoglobina: 7,0 g/dl, hematocrito: 22%, plaquetas: 50.000/mm3, blancos: 8.000/mm3, frotis con esquistocitos, poiquilocitos, anisocitosis y disminución de las plaquetas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura inmune trombocitopénica
B) Síndrome de Evans
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Púrpura trombótico trombocitopénico
E) Lupus eritematoso sistémico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un PTT clásico (pregunta difícil), que se caracteriza por 1. trombopenia, 2. anemia hemolítica (LDH alta y esquistocitos, junto a la hiperbilirrubinemia indirecta), 3. falla renal (creatinina elevada, HTA) y 4. compromiso nervioso tanto central (convulsiones, compromiso de conciencia) como periférico (parestesias migratorias). El síndrome de Evans es una anemia hemolítica autoinmune, asociada a trombopenia autoinmune (pero le sobra la falla renal). El lupus sí puede verse así exactamente, pero es un hombre y, lo más importante, es un PTT clásico.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 22 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

Un paciente de 20 años consulta por la aparición de lesiones cutáneas en las extremidades inferiores de 7 días de evolución. Al examen Fsico se observan abundantes petequias y algunas equimosis, por lo que se solicita un hemograma muestra, que muestra hematocrito 34%, hemoglobina 11,3 g/dL, glóbulos blancos 9.000/mm³ y plaquetas 15.000/mm³. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Prednisona oral en dosis altas más rituximab endovenoso
B) Transfusión de plasma fresco congelado
C) Transfusión de tres unidades de plaquetas
D) Derivar para esplenectomía
E) Dexametasona endovenosa más inmunoglobulina G endovenosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una púrpura trombocitopénica inmune (PTI) aguda. Por tener menos de 20.000 plaquetas está indicado el uso de cor<coides, lo que se podrían dar por vía oral sin mayor problema, ya que no Gene hemorragias graves actualmente. Si las tuviera, sin duda, el tratamiento serían los cor<coides EV más IgG EV, que dejaremos como respuesta correcta por ser la única con algún sentido. El rituximab se usa únicamente en la PTI crónica (esta es aguda), cuyo tratamiento de primera línea son los cor<coides orales, con el objetivo de plaquetas estables sobre 20.000. De segunda línea, se usa la esplenectomía (80% de éxito, pero quirúrgico) o el rituximab (50% de éxito, no quirúrgico; ambos producen inmunodepresión.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 5 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 21 semanas, presenta un cuadro de malestar general marcado, asociado a confusión en el último tiempo. Al examen físi- co está desorientada, tiene petequias en abdomen y extremidades y equimosis en am- bas extremidades inferiores. Se controlan exámenes, que muestran LDH: 2.550 UI/L, he- mograma con hematocrito 29%, plaquetas: 33.000 por mm3 y frotis con abundantes es- quistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénico inmune
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Síndrome de HELLP
D) Trombocitopenia gestacional
E) Enfermedad gestacional

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
B? “Es un HELLP hasta que se demuestre lo contrario” es una frase que se repite con frecuencia en obstetricia, dado la gravedad del cuadro. Sin embargo, en este caso no hay dolor abdominal, ni se describe la ictericia u otro indicador de hepatitis. Por el otro lado, el cuadro es completamente compatible con un PTT, patología que se asocia al embarazo. Por tener más de 20 semanas creo que la respuesta es HELLP, pero es una pésima pregunta.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 167 · 1.08.1.012 · Púrpuras trombopénicos

Señora asintomática en control, sin anemia ni leucopenia, pero con trombocitopenia:

A) Repetir hemograma
B) Ninguna de las anteriores es correcta
C) Todas las anteriores son correctas
D) No se dispone de información suficiente
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Repetir hemograma). Esta clase introduce el concepto de púrpura en medicina. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Ninguna de las anteriores es correcta, Todas las anteriores son correctas) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 9 · 1.08.1.018 · Síndromes mieloproliferati

Un paciente de 54 años, presenta un cuadro de varias semanas de evolución de aste- nia, adinamia y disnea que aparecen a los grandes esfuerzos Al examen físico se apre- cia palidez de piel y mucosas, se palpa el hígado 6 cm bajo el reborde costal derecho y el bazo se palpa 10 cm bajo el reborde costal izquierdo. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito de 29% con hemoglobina de 9,6g/dL, blancos 4.200/mm3, plaque- tas 111.000/mm3 y al frotis se aprecia macrocitosis y abundantes dacriocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Mieloptisis
B) Mieloma multiple
C) Leucemia mieloide crónica
D) Mielodisplasia
E) Mielofibrosis primaria

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una mielofibrosis clásica, sin embargo, toda mielofibrosis es a su vez una mielop- tisis. No debería haber un distractor correcto.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 78 · 1.08.4.005 · Estudio de coagulopatías

Una niña de 15 años presenta hipermenorrea y menometrorragia de larga data. Se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9g/dl, hematocrito: 27%, blancos: 6.000 por mm3 y plaquetas: 240.000 por mm3. Su ecografía ginecológica es normal. La conducta más adecuada para proseguir el estudio es:

A) Resonancia magnética de pelvis
B) Prueba de progesterona
C) Biopsia de endometrio
D) Estudio de trombofilias
E) Estudio de hemostasia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, pero la hipermenorrea siempre se estudia primeramente con una ecografía transvaginal, de modo de buscar una causa anatómica. Si resulta normal y es una adolescente o si es que tiene clínica de alteraciones de la hemostasia, se debe proceder directamente al estudio de la hemostasia, en busca de una enfermedad de Von Willebrand u otra análoga.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 28 1.08.4.005 · Estudio de coagulopatías

Una paciente de 20 años, que desde los siete años presenta epistaxis frecuente y equimosis ante pequeños traumatismos, desde los 14 años tiene su menarquia con san- grado menstrual abundantes. Se solicita hemograma que muestra hematocrito 45%, VCM: 90fl, leucocitos 6.000/mm3, plaquetas 2.5000/mm3, TTPK normal, protrombinemia 85%, tiempo de sangría mayor a 8 minutos. ¿Cuál es el examen de elección para prose- guir con el estudio en este caso?

A) Mielograma
B) Citometría de flujo para receptor de la proteína IIbIIIa
C) Estudio de enfermedad de Von Willebrand
D) Niveles plasmáticos de factor VIII y factor IX de la coagulación
E) Electroforesis de proteína en sangre

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Estudio de enfermedad de Von Willebrand). Es una EvW clásica.. La epistaxis o sangrado nasal es una consulta frecuente en urgencias. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 58 1.08.1.001 · Anemia de las enfermedades

Una paciente de 52 años, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento per- manente con AINES y prednisona por vía oral y tratamiento intermitente con metotre- xate por vía oral, presenta un cuadro de astenia, adinamia y disnea de esfuerzos que ha empeorado en el último tiempo. Se solicitan exámenes en los que destacan una creatini- na de 1,6mg/dL, hemograma con hematocrito 29%, hemoglobina 9,7g/dL, plaquetas 147.000/mm3, blancos 4.200/mm3 y al frotis se aprecia microcitosis. Además se solicita perfil de fierro que muestra ferremia de 40ug/dL (60-160 ug/dL) y transferrina de 190mg/dL (240-360mg/dL). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Anemia por enfermedades crónicas
B) Mielodisplasia
C) Anemia por insuficiencia renal crónica
D) Hipoplasia medular
E) Mieloma múltiple

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por tener AR, como por la ferremia baja, con transferrina baja, orienta mu- cho a una anemia por enfermedades crónicas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 42 1.08.4.006 · Estudio de trombofilia

Un paciente consulta por dolor y aumento de volumen en la pierna derecha. ¿Qué característica del dímero D es aquella que permite descartar una trombosis venosa profunda cuando resulta negativo?

A) Alta especificidad
B) Alta sensibilidad
C) Elevado valor predictivo negativo
D) Elevado valor predictivo positivo
E) Baja especificidad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, ya que tanto alta sensbilidad, como alto valor predictivo negativo son respuestas correctas y, de hecho, se relacionan entre sí. Sin embargo, en estricto rigor, es el alto VPN lo que hace que se descarte una enfermedad al resultar negativo el examen.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 27 1.08.1.002 · Anemia ferropénica

Una paciente de 19 años, con antecedentes de sangrado menstrual abundante desde su menarquia a los 12 años y de una cirugía de by pass gástrico realizado hace un año, consulta por un cuadro de disnea e intolerancia al ejercicio, de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con hemoglobina: 9,1 g/dl, hematocrito 28%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas 300.000 por mm3; ferritina plasmática: 9 ng/ml (VN: 12 – 150 ng/ml) y saturación de transferrina 12%. La conducta más adecuada es:

A) Indicar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Administrar folatos orales
D) Administrar vitamina B12 por vía intra muscular
E) Transfundir glóbulos rojos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Anemia ferropénica con indicación de hierro endovenoso: El diagnóstico es una anemia moderada ferropénica, confirmada por la ferritina plasmática baja (reflejo de los depósitos de hierro) y la saturación de transferrina menor al 20%. La paciente requiere suplementación de hierro, y en este caso, la vía debe ser endovenosa debido a la cirugía de bypass gástrico, un factor de riesgo para la malabsorción de hierro, ya que se absorbe principalmente en el duodeno, por lo que las cirugías en esta área pueden afectar su absorción, similar a lo que ocurre en la enfermedad celíaca, donde el duodeno suele ser el segmento intestinal más afectado.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 166 1.08.1.002 · Anemia ferropénica

Una paciente de 28 años se encuentra en su quinto día postparto, tras el cual presentó atonía uterina que se manejó farmacológicamente. En el examen físico, presenta palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita hemograma, que muestra hemoglobina: 8.6 g/dL y hematocrito: 25%. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar hierro por vía oral
B) Administrar hierro por vía endovenosa
C) Realizar una transfusión de glóbulos rojos
D) Administrar un uterotónico
E) Administrar ácido fólico y vitamina B12

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Suplementación de Hierro en Anemia Posparto: En una paciente con anemia moderada secundaria a hemorragia posparto, se recomienda la suplementación con hierro para compensar las pérdidas, incluso si no se ha confirmado la deficiencia de hierro. La vía de administración puede ser oral o intravenosa. La vía oral suele ser suficiente para una recuperación completa, por lo que suele ser la de elección, mientras que la vía intravenosa ofrece una recuperación más rápida del hematocrito y es una alternativa del todo aceptable.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 18 · 1.08.1.002 · Anemia ferropénica

Un paciente de 71 años presenta un cuadro de dos meses de adinamia, astenia y disnea de medianos esfuerzos, progresiva. Al examen físico se observa importante palidez de piel y mucosas, por lo que se piden exámenes entre los que destacan hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,8 g/dl, VCM: 65 fl, plaquetas: 400.000 por mm3, blancos: 5.600 por mm3, frotis: microcitosis, hipocromía, poiquilocitosis y anisocitosis, transferrina: 460 ug/dl y ferremia: 24 ug/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Solicitar biopsia de médula ósea
B) Realizar estudio endoscópico del tubo digestivo
C) Solicitar ferritina plasmática
D) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
E) Transfundir glóbulos rojos

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy discutible, ya que tiene una clara anemia ferropénica, grave y se debe estudiar la presencia de cáncer digestivo, ya que es un adulto mayor. Sin embargo, probablemente sí se lo deba transfundir, ya que tiene una anemia muy sintomática. Por regla general, pero no absoluta, no se transfunden si tiene Hb mayor o igual a 10 g/dl y se suelen transfundir casi todos, si está menor a 7 g/dl. Entre 7 y 10, se ve caso a caso (aunque siempre se ve caso a caso). Dada la forma en que está redactada, recomiendo marcar la transfusión.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 133 · 1.08.4.004 · Electroforesis de proteína

Un paciente de 78 años, consulta por lumbago de un mes de evolución, progresivo e intenso, que no ha respondido bien a analgésicos. En su examen físico se observa con IMC: 20, FC: 75x'. PA: 126/86 mmHg, cabeza y cuello sin alteraciones, cardiopulmonar normal y examen lumbar con limitación de los movimientos, por dolor. Trae exámenes, que muestran hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 10,5 g/dl, plaquetas: 88.000 por mm3, glóbulos blancos: 4.300 por mm3, con fórmula diferencial normal, VHS: 78 mm/h, creatinina: 2,2 mg/dl, natremia: 135 mEq/, potasemia: calcemia 10,5 mg/dl, proteínas totales: 8,9 g/dl, albúmina: 2,9 g/dl. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Electroforesis de proteínas en sangre
B) Densitometría ósea
C) Radiografía de huesos largos y cráneo
D) Estudio citogenético de médula ósea
E) Niveles plasmáticos de vitamina B12

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Electroforesis de proteínas en sangre** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 20 · 1.08.2.005 · Lisis tumoral aguda

Un paciente de 55 años, diagnos8cado con un linfoma no Hodgkin con múl8ples masas medias`nicas y abdominales de gran tamaño, de hasta 25 cm, inicia quimioterapia endovenosa. Al tercer día evoluciona con malestar general marcado, obnubilación y disnea. Al examen Fsico, se aprecia desorientado en el 8empo y el espacio, en malas condiciones generales y se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan ácido úrico: 13 mg/dL, sodio: 140 mEq/L, potasio: 5,9 mEq/L, fósforo: 6,5 mg/dl, crea8nina plasmá8ca: 2,1 mg/dl y hematocrito 22%. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hipercalcemia maligna
B) Metástasis cerebrales
C) Síndrome de vena cava superior
D) Síndrome de compresión medular
E) Síndrome de lisis tumoral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome de lisis tumoral clásico, con rotura celular masiva, que se refleja en hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfemia, hipocalcemia, acidosis, falla renal, compromiso de conciencia, compromiso hemodinámico. Se trata con hidratación, hipouricemiantes (ej. alopurinol) y manejo de los electrolitos según las alteraciones (ej. Bicarbonato, calcio, furosemida, insulina más glucosa, resinas de intercambio como el sulfonato de poliestireno, etc.).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 63 · 1.08.2.005 · Lisis tumoral aguda

Paciente con linfoma en quimioterapia. Post primer ciclo presenta hiperuricemia, hiperkalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Creatinina en ascenso. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de lisis tumoral
B) Insuficiencia renal aguda prerenal
C) Nefrotoxicidad por cisplatino
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Hiperparatiroidismo secundario

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Post quimioterapia: hiperuricemia + hiperkalemia + hiperfosfatemia + hipocalcemia + IRA = síndrome de lisis tumoral. Ocurre por destrucción masiva de células tumorales que liberan su contenido.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 106 · 1.08.2.005 · Lisis tumoral aguda

Paciente con leucocitosis, 80% blastos linfoides, hiperuricemia, hipocalcemia y fósforo límite alto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Quimioterapia de inducción inmediata
B) Rasburicasa e iniciar quimioterapia
C) Transfusión de glóbulos rojos y plaquetas
D) Hemodiálisis urgente
E) Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral)** (opción **E**). Suero fisiológico endovenoso y alopurinol (prevención de síndrome de lisis tumoral). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 168 1.08.4.008 · Hemograma

Paciente con cáncer de mama en quimioterapia hace 9 días, hace 3 días comienza con fiebre. ¿Cuál es el examen inicial para iniciar estudio?

A) Hemograma
B) Hemocultivos periféricos x2
C) TAC de tórax-abdomen-pelvis
D) PCR y procalcitonina
E) Uroanálisis y urocultivo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Hemograma). Hemograma. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Hemocultivos periféricos x2, TAC de tórax-abdomen-pelvis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 171 1.08.4.003 · Biopsia de médula ósea

Paciente con dolores óseos, anemia normocítica, VHS >90 y creatinina elevada. ¿Cuál es el estudio para confirmar el diagnóstico?

A) Proteína de Bence-Jones en orina
B) Electroforesis de proteínas séricas
C) TAC de cuerpo completo dosis baja
D) Biopsia ósea de lesión lítica
E) Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético** (opción **E**). Aspirado y biopsia de médula ósea con estudio citogenético. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 142 1.08.3.012 · Tratamiento anticoagulante

Paciente en tratamiento con acenocumarol (warfarina) por FA. INR actual: 7.8 (meta 2-3). Sin sangrado activo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender acenocumarol y administrar vitamina K1 oral 2.5-5 mg
B) Transfusión de plasma fresco congelado urgente
C) Solo suspender el anticoagulante y observar
D) Administrar protamina
E) Continuar la misma dosis y controlar en 1 semana

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

INR >5 sin sangrado: suspender anticoagulante + vitamina K1 oral 2.5-5 mg para reversión gradual. Plasma fresco solo si hay sangrado mayor. Objetivo: no revertir completamente para no crear estado protrombótico.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 150 1.08.3.012 · Tratamiento anticoagulante

Paciente con ERC, con TVP poplítea, cual es la mejor terapia anticoagulante: a. Heparina no fraccionada

B) Enoxaparina
C) Dabigatran
D) Rivaroxaban
E) Acenocumarol 151. Mujer fumadora, hipertensa, con historia de ICC, pero que ahora estaba como desde hace unos 3 meses? Con disnea de esfuerzo, y al examen pulmonar estaba con sibilancias espiratorias,, y preguntaban por la causa del empeoramiento de los síntomas?
A) TEP

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Enoxaparina). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Dabigatran, Rivaroxaban) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 14 1.08.3.011 · Transfusión y sus complica

Una paciente de 68 años sufre un accidente de tránsito, resultando con fractura de pelvis inestable y hemorragia masiva, ingresando para su manejo en la unidad de paciente crítico. Al examen físico está taquicárdica e hipotensa, por lo que se solicitan pruebas de grupo y Rh, resultando su grupo sanguíneo O-Rh negativo. Sin embargo, en el hospital únicamente hay dos unidades de glóbulos rojos O-Rh negativo, aunque múltiples unidades O-Rh positivo. El hospital más cercano con unidades O-Rh negativo disponibles está a 4 horas de traslado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar cristaloides hasta conseguir más unidades O-Rh negativo
B) Administrar las dos unidades O-Rh negativo y, en caso necesario, las O-Rh positivo
C) Esperar a obtener más unidades O-Rh negativo, solicitándolas de inmediato a otro centro
D) Administrar únicamente las dos unidades O-Rh negativo disponibles
E) Trasladar de inmediato a otro hospital que tenga disponibles unidades O-Rh negativo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Compatibilidad de Grupos Sanguíneos: Las personas con sangre tipo O pueden donar a todos los grupos sanguíneos, pero solo pueden recibir sangre tipo O (son donantes universales), aunque actualmente se prefiere transfundir sangre del mismo tipo y, previo a la transfusión se realizan pruebas cruzadas, que aseguren que el riesgo de hemólisis transfusional es mínimo. Las personas con grupo Rh negativo pueden donar a personas Rh positivo, pero idealmente solo deben recibir sangre Rh negativo. Sin embargo, a diferencia del grupo clásico ABO, en el caso del grupo Rh, excepcionalmente, se puede transfundir sangre Rh positivo a pacientes Rh negativo en situaciones críticas con riesgo de muerte, como en este caso, ya que el riesgo de hemólisis es menor que con el grupo clásico y, obviamente, menor que el riesgo dado por la anemia aguda severa.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 37 1.08.5.002 · Biopsia ganglionar

Un hombre de 30 años presenta aumento de volumen en el cuello, desde hace dos meses, que ha progresado desde ese entonces. Además, ha presentado sudoración nocturna y fiebre ocasional. Al examen físico, tiene signos vitales normales y se constata presencia de una adenopatía de 3 x 2 cm, ubicada en el triángulo anterior del cuello. Su examen cardiopulmonar no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para confirmar el diagnóstico?

A) Hemograma VHS
B) Biopsia de médula ósea
C) Serología para citomegalovirus
D) Biopsia ganglionar
E) Serología para virus de Epstein Barr

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Linfoma de Hodgkin: La sospecha clínica es un linfoma de Hodgkin, debido a la presencia de síntomas B y la adenopatía. El diagnóstico se confirma mediante biopsia excisional de uno de los ganglios.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 96 1.08.2.002 · Coagulopatía adquirida

Un paciente de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial y una válvula cardíaca aórtica mecánica, anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, ingresa al servicio de urgencias por un episodio de hemorragia digestiva alta, con signos de inestabilidad hemodinámica. Además de la administración de fluidos y la solicitud de una endoscopía digestiva alta con urgencia, ¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Administrar vitamina K por vía endovenosa
B) Transfundir sangre completa
C) Administrar ácido tranexámico endovenoso
D) Administrar plasma fresco congelado endovenoso
E) Administrar factor VII recombinante endovenoso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

ntídoto para los Cumarínicos: El antídoto para los cumarínicos o antagonistas de la vitamina K varía según la urgencia para revertir su efecto. Reversión inmediata: Se debe administrar plasma fresco congelado. Reversión no urgente: Se debe administrar vitamina K.

REUMATOLOGÍA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 09

64 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

18 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.11.1.001	Artritis psoriática	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 09 · 9.18 (Pág. 68)
1.11.1.002	Artritis reactivas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 17 · 17.4 (Pág. 17)
1.11.1.003	Artritis reumatoídea	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	10 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.004	Artrosis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.007	Condrocalcinosis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.009	Esclerosis sistémica progresiva	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.010	Fibromialgia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.014	Lupus eritematoso sistémico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.015	Monoartritis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.017	Osteoporosis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.018	Pelviespondilopatías seronegativas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.020	Polimiositis, dermatomiositis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 09 · 9.13 (Pág. 51)
1.11.1.021	Síndrome antifosfolípidos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.022	Síndrome de Sjögren	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.1.025	Vasculitis sistémicas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.2.001	Artritis séptica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.2.002	Gota aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)
1.11.4.002	Estudio de líquido sinovial	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 09 · Reumatología (Pág. 8)

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 94 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Paciente con dolor articular en MCF e IFP, con rigidez matinal importante. ¿Cuál es el examen específico a solicitar?

A) Factor reumatoide (IgM)
B) ANA y anti-DNA doble cadena
C) Ácido úrico sérico
D) Anticuerpos anti-CCP
E) HLA-B27

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Anticuerpos anti-CCP). Anticuerpos anti-CCP. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Factor reumatoide (IgM), ANA y anti-DNA doble cadena) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 20 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión en tratamiento, con cuadro de tres meses de dolor en ambas manos y muñecas, asociados a rigidez matinal de 2 horas de evolución. Al examen físico se aprecia compromiso en ambas manos de articulaciones metacarpofalángica e interfalangicas proximales. Se solicita radiografía de manos que muestra erosión de la base de la quinta articulación metacarpofalángica. Además se solicita factor reumatoídeo que resulta negativo y péptido citrulinado que también resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

A) Artritis reumatoídea
B) Artritis psoriática
C) Osteoartritis
D) Espondilitis anquilosante
E) Lupus con compromiso articular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Artritis reumatoídea** (opción **A**). Es una AR de libro, aunque tenga negativos los marcadores.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 96 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una paciente de 50 años consulta por artralgias y edema de las manos, especialmente en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en las muñecas de ambas manos. Refiere fenómeno de Raynaud y rigidez matinal de 1 hora de duración. Además, relata sensación de arenilla ocular, hipolacrimia y xerostomía. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma normal, VHS: 52 mm/h, PCR: 2,8 mg/dl, ENA (-), AntiDNA 2h (-) y anticuerpos anti- CCP mayores a 200 UI/ml. La radiografía de manos muestra edema de partes blandas y osteopenia yuxtarticular de los huesos metacarpianos. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus eritematoso sistémico
B) Artritis reumatoide
C) Artritis psoriática
D) Esclerosis sistémica
E) Síndrome de Sjörgren primario

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Artritis reumatoide** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 132 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una paciente de 54 años ha presentado dolores simétricos en pequeñas y grandes articulaciones, con compromiso de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que iniciaron hace un año, y que se asocian a rigidez matinal de más de una hora y a sensación de arenilla y sequedad ocular. Se solicitan exámenes que muestran PCR: 10, factor reumatoideo: negativo, anticuerpos antinucleares: negativo y anticuerpos anti- CCP negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reumatoidea
B) Artritis reactiva
C) Artrosis
D) Atritis psoriatica.
E) Síndrome de Sjörgren primario

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Artritis reumatoidea** (opción **A**). Aunque los marcadores estén negativos, es una AR clásica. Tiene además un Sjögren secundario.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 160 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una mujer de 50 años, sin antecedentes, presenta cuadro de dos meses de dolor en ambas manos asociados a rigidez matinal de 40 minutos de duración que disminuye con los movimientos. Al examen físico destaca eritema en articulaciones metacarpofalangicas de ambas manos, sin otros síntomas. Se solicita factor reumatoideo que resulta positivo y péptido citrulinado que resulta negativo. El tratamiento de elección para esta enfermedad es:

A) Metotrexato
B) Inmunoglobulina G no específica
C) Antiinflamatorios no esteroidales
D) Corticoides
E) Hidroxicloroquina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Metotrexato** (opción **A**). Es una AR, aunque tenga negativo el anti-CCP. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 128 · 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una paciente de 50 años consulta por artralgias y edema de las manos, especialmente en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y en las muñecas de ambas manos. Refiere fenómeno de Raynaud y rigidez matinal de 1 hora de duración. Además, relata sensación de arenilla ocular y boca seca. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma normal, VHS: 52 mm/h, PCR: 2,8 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/80, factor reumatoide: 118 UI/ml y anticuerpos anti-CCP: 200 UI/ml. La radiografía de manos muestra osteopenia yuxtarticular de los huesos metacarpianos. El diagnóstico más probable es:

A) Lupus
B) Artritis reumatoide
C) Vasculitis primaria
D) Esclerosis sistémica
E) Síndrome de Sjörgren primario

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Artritis reumatoide** (opción **B**). Es una AR clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 46 · 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Mujer con dolor en metacarpofalángicas, IFP y rodillas, con dolor matutino mayor a 1 hora ¿Cuál es el diagnóstico? a. Artritis Reumatoide

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hemograma y VHS** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 130 · 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una paciente de 45 años consulta por dolores articulares en muñecas, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos, asociado a dolor en el codo derecho y la rodilla izquierda. Además, se queja de rigidez matinal, que dura cerca de 4 horas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema y aumento de la temperatura local de varias de las articulaciones descritas. ¿Cuál es el examen más específico para el diagnóstico de esta patología?

A) Anticuerpos anti DNA nativo
B) Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos
C) Anticuerpos antinucleares
D) Anticuerpos anti-CCP
E) HLA B27

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Anticuerpos anti-CCP** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 46 · 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una paciente de 39 años consulta por deseos de embarazo. Tiene antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con paracetamol. Refiere artralgias de manos con frecuencia. Al examen físico no tiene signos inflamatorios, salvo en una de las articulaciones metacarpofalángicas derechas. Trae factor reumatoideo y anticuerpos antiCCP positivos a títulos elevados y una radiogargía de manos, con lesiones erosivas en algunas articulaciones interfalángicas proximales. ¿Cuál es el tratamiento más indicado en esta paciente?

A) Metotrexato
B) Leflunomide
C) Azulfidine
D) Anticuerpos contra el receptor de TNF alfa
E) Plaquinol

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La AR se trata con infliximab en el embarazo. De todos modos, es una pregunta específica, que excede lo que un médico general debe saber.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 5 · 1.11.1.003 · Artritis reumatoídea

Una mujer de 40 años presenta artralgias y rigidez matinal, que afecta especialmente las muñecas, articulaciones metacarpofalángicas y, desde hace algunos meses, también afecta los tobillos y articulaciones metatarsofalánficas. Al examen tiene artritis de varias a de las articulaciones descritas. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para determinar el curso clínico de la enfermedad?

A) Velocidad de sedimentación hemática
B) Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
C) Anticuerpos antipéptido citrulinado
D) Proteína C reactiva
E) Anticuerpos antinuclerares

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto en la AR, como en el LES, los marcadores (FR y Anti-CCP para la AR y Anti-DNA2h para el LES) son 1. elementos diagnósticos y 2. marcadores de agresividad. En ambos casos, eso sí, el principal determinante del pronóstico es la clínica, que mientras más agresiva, refractaria, etc. sea, peor.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 47 · 1.11.2.002 · Gota aguda

Un paciente de 45 años ha presentado 3 episodios de gota en el último año, por lo que se inició tratamiento colchicina y luego se agregó alopurinol 100 mg/día. Actualmente está asintomático, sin signos de artritis y se controlar uricemia de 7 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender el tratamiento
B) Aumetar la dosis de alopurinol a 300 mg/día
C) Agregar probenecid al tratamiento
D) Suspender la colchicina
E) Agregar prednisona en baja dosis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La colchicina tiene muchos efectos adversos, por lo que se prefiere no dejarla como tratamiento profiláctico, sino solo en las crisis agudas (en agudo los AINEs son de elección). EL alopurinol debe mantenerse, ya que tuvo más de 2 crisis en 1 año y actualmente tiene buenos niveles de ácido úrico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 30 1.11.2.002 · Gota aguda

Un paciente de 56 años, hipertenso y dislipidémico, en tratamiento con hidroclorotiazida y atorvastatina, consulta por dolor muy intenso en el pie derecho, especialmente en el primer ortejo, que inició hace algunas horas. Al examen físico tiene eritema del ortejo, el que es muy doloroso a la movilización. Se observa edema en dicho ortejo y en la zona bimaleolar. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma, con leucocitos de 12.000 por mm3, PCR: 2 (VN: menor a 1 mg/L), ácido úrico: creatinina: 0,8 mg/dl. ¿Cuál es el primer fármaco que debe administrarse para el manejo actual de este paciente?

A) Diclofenaco sódico
B) Cloxacilina
C) Alopurinol
D) Prednisona
E) Clindamicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La gota aguda se trata con AINEs (la HCTZ es un desencadenante). También sirve la colchicina. El alopurinol jamás se inicia en agudo.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 34 1.11.2.002 · Gota aguda

Un paciente de 48 años, obeso e hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida consulta por dolor muy intenso y aumento de volumen en relación al primer ortejo derecho, de 24 horas de evolución. Al examen físico, tiene FC: 80x', PA: 144/96 mmHg, T°:37°C y se aprecia aumento de volumen y eritema de la primera articulación metatarsofalángica de ese pie, asociado a intenso dolor a la movilización. Refiere que ya había tenido un episodio similar hace un año. ¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo de este paciente?

A) Diclofenaco
B) Metotrexato
C) Cloxacilina
D) Alopurinol
E) Prednisona

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Gota Aguda: El diagnóstico es una crisis de gota aguda, probablemente desencadenada por el uso de hidroclorotiazida (se debe cambiar por otro antihipertensivo como el amlodipino). El tratamiento de la crisis se puede realizar con AINEs, prednisona o colchicina. Aunque los AINEs son la recomendación tradicional en Chile, las guías internacionales sugieren corticoides como primera línea (por lo que la dejaremos como respuesta correcta). Dado el episodio previo, se debe indicar alopurinol para controlar el ácido úrico, pero no se espera un beneficio inmediato al añadirlo en este momento.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 112 1.11.2.002 · Gota aguda

Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de podagra. Tiene antecedente de dos crisis similares en los últimos 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Paracetamol
B) Colchicina
C) Probenecid
D) Alopurinol
E) Prednisona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy complicada, ya que en el cuadro agudo actual (podagra) se debe indicar AINEs de elección y, si no está en las opciones, pues se indica la colchicina. Además, el hecho de que haya tenido más crisis en el último año (1 o más en un año) obliga a iniciar alopurinol, aunque no es posible iniciarlo ahora en agudo, mientras está con la podagra, sino que se debe esperar a que se resuelva, razón por la cual la respuesta es colchicina.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 55 1.11.2.002 · Gota aguda

Un paciente de 70 años, con cuadro de 2 horas de dolor y ardor en pie derecho. Al examen físico destaca eritema en primera articulación metacarpofalángica de pie derecho, sin otras alteraciones. Refiere que ha presentado este mismo cuadro en dos ocasiones en los últimos 6 meses. El tratamiento de elección en este paciente es:

A) Probenecid
B) Alopurinol
C) Coritoides
D) Paracetamol
E) Colchicina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El tratamiento de elección de la gota aguda son los AINES. La Colchicina es la opción más adecuada dentro de las que ahí aparecen. La Colchicina sí sirve en la gota aguda, aunque por tener muchos efectos adeversos, se prefieren los AINES. El alopurinol está contraindicado en la gota aguda.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 116 1.11.1.002 · Artritis reactivas

Un paciente de 20 años, con antecedente de gastroenteritis aguda hace dos semana, consulta por dolor en tobillo derecho desde hace 1 día. Refiere haber presentado molestias similares hace una semana en rodilla y pie izquierdo. Al examen físico destaca tobillo derecho con eritema leve, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Artritis por cristales
B) Artritis por stafilococo aureus
C) Artritis por neisseria gonorrhoeae
D) Artritis reactiva
E) Artritis reumatoídea juvenil

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Artritis reactiva** (opción **D**). Oligoartritis migratoria es probablemente una reactiva. En especial si la diarrea fue por Campilobacter.. El trastorno adaptativo es una respuesta psicológica a un evento estresante identificable (gatillante) que no cumple criterios de depresión ni de otro trastorno específico. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 8 1.11.4.002 · Estudio de líquido sinovia

Un adulto mayor presenta gonalgia bilateral, de dos años de evolución, que aumenta con la marcha. Hace algunas horas el dolor de la rodilla izquierda se vuelve mucho más intenso, apareciendo eritema, aumento de volumen y sensacion febril. ¿Cuál es el examen más adecuado para este paciente?

A) Resonancia magnética de rodilla
B) Radiografía de rodilla
C) Hemograma VHS
D) Estudio de líquido articular
E) TAC de rodilla

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Estudio de líquido articular). Es una artritis séptica: estudiar el líquido es la forma de diagnosticarla. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 72 · 1.11.1.018 · Pelviespondilopatías seron

Un paciente de 39 años, trabajador de la construcción, con IMC de 30, psoriático, consulta por dolor en la zona glútea profunda, de predominio nocturno, muy intenso y que va desapareciendo en la mañana, a medida que realiza sus actividades. El dolor inició hace 3 meses y ha aumentado. Hace 2 meses presentó una uveítis derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Radiculopatía S1
B) Espondiloartritis
C) Espondilodiscitis
D) Hernia del núcleo pulposo con compresión del plexo lumbar
E) Raquiestenosis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una espondilitis anquilosante clásica tanto por el lumbago inflamatorio (mayor en la noche y en el reposo) como por la uveítis.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 125 · 1.11.1.018 · Pelviespondilopatías seron

Un paciente de 23 años presenta dolor lumbar, irradiado a ambas piernas, de 2 años de evolución, y que suele ser mayor en la noche. Además presenta dolor torácico, que aumenta con los movimientos respiratorios. El dolor cede parcialmente con AINEs. Refiere un cuadro de artritis de rodilla derecha, autolimitado, hace un año. Al examen físico presenta restricción a los movimientos torácicos y a limitación de la flexión lumbar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Factor reumatoide
B) Resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas
C) TAC de columna lumbosacra
D) Radiografía de tórax
E) Hemograma y VHS

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una espondilitis anquilosante. Si bien el mejor examen es la resonancia magnética nuclear de sacroiliacas, se suele pedir una radiografía de sacroiliacas, como primer examen, ya que tiene buen rendimiento en los pacientes con mucho tiempo con síntomas. El FR está negativo. También sirve de apoyo el HLA-B27

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 110 · 1.11.1.018 · Pelviespondilopatías seron

Paciente 27 años con espondilopatia o era sacroileítis?'?, cual es el tratamiento inicial:

A) Ibuprofeno
B) Prednisona
C) Paracetamol (porque no puede paracetamol??)
D) Amoxicilina
E) Omeprazol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ibuprofeno** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Prednisona, Paracetamol (porque no puede paracetamol??)) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 97 · 1.11.1.018 · Pelviespondilopatías seron

Un paciente de 23 años consulta por dolor lumbar y en la zona glútea, de 1 año de evolución, que es mayor en las mañanas y al dormir y que va cediendo a medida que realiza sus actividades durante el día. Además, ha presentado dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que luego desapareció espontáneamente. Al examen físico tiene placas descamativas en las rodillas, depresiones ungueales, dolor a la compresión prueba de Lasegue negativa, prueba de Schöbber 2 cm. En sus exámenes destaca ANA negativos y factor reumatoide, dentro de límites normales. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Radiografía de columna lumbosacra
B) Tomografía de columna dorsolumbar
C) Radiografía de tórax
D) Resonancia magnética nuclear de articulaciones sacroilíacas
E) ANCA, C3 y C4

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene clínica de una pelviespondiloartropatía (PEA). Además, las lesiones cutáneas orientan fuertemente a artritis psoriática. La RMN es el mejor examen para las PEA, pero La radiografía simple de sacroilíacas (ej. lumbosacra) suele ser el primer examen a solicitar, dado que es barato, está disponible y entrega mucha información. En la artritis psoriática la RMN es muy importante y debe solicitarse, pero la radiografía sigue siendo el primer examen. Las pruebas serológicas no sirven, ya que resultan negativas.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 103 · 1.11.2.001 · Artritis séptica

Una paciente de 61 años, hipertensa y diabética, en tratamiento regular con hipoglicemiantes orales y antihipertensivos, desde hace 3 días presenta dolor y aumento de volumen en hombro derecho. Al examen físico presenta temperatura 38,2 ºC, eritema, rubor y aumento de volumen del hombro derecho y limitación funcional, que impide el movimiento. El diagnóstico más probable es:

A) Gota
B) Condrocalcinosis
C) Artritis reumatoidea
D) Artritis séptica
E) Artritis reactiva

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La fiebre y que afecte el hombro, orienta mucho a que es una A. séptica. Faltan datos como para pensar en condrocalcinosis que es otra de las causas de monoartritis aguda (afectan más otras articulaciones: rodilla en condrocalcinosis).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 95 1.11.2.001 · Artritis séptica

Un paciente de 68 años presenta monoartritis de rodilla izquierda, desde hace 48 horas. Al examen físico se observa aumento de volumen con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular poco filante, con 50.000 glóbulos blancos por mm3, sin presencia de cristales. Lo más probable es que se trate de una artritis:

A) Reactiva
B) Seronegativa
C) Reumatoide
D) Séptica
E) Psoriática

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil, ya que el líquido está en el límite entre séptico (más de 50.000 glóbulos blancos) e inflamatorio. Ambas tienen filancia disminuida. La falta de antecedente de lesiones cutáneas hace improbable una psoriasis. Así mismo, la ausencia de infección previa hace improbable la séptica. La ausencia de otros síntomas (ej. lumbago) hace improbable la pelviespondilopatía seronegativa. Por tanto, por descarte y a pesar de que no se ven bacterias, el diagnóstico es una artritis séptica.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 39 1.11.2.001 · Artritis séptica

Una paciente de 67 años consulta por un cuadro de dolor e impotencia funcional del codo derecho, asociado a fiebre, que inició hace 2 días. Al examen físico tiene temperatura de 39 grados Celsius, FC: 100x' y PA: 110/70 mmHg, asociado a aumento de volumen del codo derecho, con eritema y aumento de la temperatura local. Además, tanto la movilidad pasiva, como la activa, son muy dolorosas. ¿Cual es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reactiva
B) Artritis séptica
C) Artritis gotosa
D) Condrocalcinosis
E) Artritis reumatoide

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por afectar el codo y por la fiebre alta, es séptica. La reactiva, habitualmente no es tan dolorosa, no tiene fiebre y está precedida por alguna infección (diarreas por lo general). La gotosa y la condrocalcinosis pueden ser muy dolorosas, pero es infrecuente la fiebre (igual pueden tener) y afecta generalmente otras articulaciones (primera metatarsofalángica: gota y rodilla: condrocalcinosis).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 172 1.11.2.001 · Artritis séptica

Un hombre de 77 años, alérgico a la penicilina, consulta por dolor de la rodilla iz- quierda, asociado a aumento de volumen y fiebre. Al examen físico tiene temperatura de 38,5 grados y presenta aumento de volumen y eritema de la rodilla izquierda, asocia- do a signos de derrame articular. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?

A) Cefazolina endovenosa
B) Cloxacilina endovenosa
C) Azitromicina oral
D) Clindamicina endovenosa
E) Gentamicina endovenosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una mala pregunta, ya que no indican el nivel de alergia la penicilina. En ge- neral, la alergia a la penicilina no contraindica a las cefalosporinas y la cefazolina es más potente antibiótico que la clindamicina. Sin embargo, si es que ha habido un shock anafilático o angioedema, sí se contraindican las cefalosporinas. La clindamicina es una buena opción y no tiene ninguna contraindicación por la alergia.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 102 1.11.1.004 · Artrosis

Una paciente de 61 años consulta por dolor articular de ambas manos. Al examen se aprecia aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Se solicita radiografía de manos, que muestra disminución simétrica del espacio interarticular de las articulaciones interfalángicas, con compromiso de la primera articulación carpometacarpiana bilateral, con presencia de quistes subcondrales. Los ANA y FR resultan positivos. El diagnóstico más probable es:

A) Artritris psoriática
B) Artriris reumatoide
C) Artritis reactiva
D) Condrocalcinosis
E) Artrosis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto la clínica (compromiso de IFD, IFP y primera CMC), como la radiografía son clásicas de artrosis. No importa la positividad de marcadores, ya que están positivos en un 5% de las personas sanas y solo tienen importancia cuando la clínica es de Lupus o Artritis reumatoide, que no es el caso.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 121 1.11.1.004 · Artrosis

Una paciente de 64 años consulta por artralgias de las manos, caderas y rodillas. Al examen físico presenta aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas, con nódulos de Heberden. Además tiene limitación de los movimientos de las rodillas, con dolor y crepitación articular, sin signos inflamatorios y limitación a la abducción ambas caderas. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Prednisona
B) Paracetamol
C) Metotrexato
D) Bifosfonatos
E) Ibuprofeno

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Paracetamol** (opción **B**). La primera línea de tratamiento en la artrosis, es el paracetamol.. el tratamiento hay que saberlo bien, De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 95 1.11.1.004 · Artrosis

Paciente con artralgias en IFD e IFP, rigidez matinal de 3-5 minutos, dolor que aumenta con actividad. Radiografía: disminución de espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos. ¿Diagnóstico?

A) Artritis reumatoide
B) Artrosis
C) Artritis psoriásica
D) Artritis gotosa crónica
E) Espondilitis anquilosante

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Artrosis** (opción **B**). Artrosis. A todos, con este video vamos a empezar con el tema de reumatología y los primeros dos temas que vamos a ver son artrosis y la monotítica y aguga, que incluye artítica por cristales y además la artítica y séptica. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 137 1.11.1.004 · Artrosis

Una paciente de 63 años presenta dolor en articulaciones de las manos, mayores en las articulaciones interfalángicas distales y proximales, asociadas a rigidez matinal de 5 minutos. Además, refiere dificultades para las actividades que requieren mayor prensión de las manos. Se realiza radiografía de manos, que muestra disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis reumatoide
B) Artritis psoriática
C) Osteoartritis
D) Osteoporosis
E) Artritis reactiva

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Osteoartritis** (opción **C**). A todos, con este video vamos a empezar con el tema de reumatología y los primeros dos temas que vamos a ver son artrosis y la monotítica y aguga, que incluye artítica por cristales y además la artítica y séptica. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 148 1.11.1.017 · Osteoporosis

Una paciente de 66 años, que mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, se realiza una den- sitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la co- lumna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquí- mico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. ¿Cuál es la conducta más ade- cuada para esta paciente?

A) Indicar calcio y vitamina D vía oral
B) Indicar una carga de vitamina D vía oral
C) Administrar calcitonina endovenosa
D) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
E) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5), por lo que se debe iniciar bifosfonatos. Sin embargo también tiene que recibir vitamina D y calcio. No debería ha- ber distractores correctos.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 121 1.11.1.017 · Osteoporosis

Una paciente de 65 años, menopáusica hace 15 años, sufrió una fractura de muñeca derecha hace un año y recientemente sufrió una fractura de cadera derecha. La densitometría ósea muestra un T-score de -3 en la zona lumbar, -2.7 en la cadera derecha y -2.5 en la cadera izquierda. Además de indicar una adecuada ingesta de calcio y vitamina D, ¿cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

A) Alendronato 70 mg semanal
B) Risedronato 150 mg semanal
C) Ácido zoledrónico 5 mg cada 6 meses
D) Terapia de reemplazo hormonal
E) Denosumab endovenoso

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tratamiento de la Osteoporosis: El tratamiento de la osteoporosis generalmente incluye la ingesta de calcio, vitamina D y bifosfonatos. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tipos de bifosfonatos, y la principal diferencia entre ellos radica en la periodicidad con la que se administran. El alendronato se administra semanalmente, el ibandronato mensualmente, y el ácido zoledrónico semestral o anualmente. Sin embargo, en casos de osteoporosis severa, definida por un T-score menor a -3 o por la presencia de fracturas osteoporóticas (como en este caso), se recomienda el tratamiento con anabólicos óseos, en lugar de bifosfonatos (teriparatida y romosozumab). El denosumab es una opción aceptable en estos casos. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la acción de los osteoclastos.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 37 1.11.1.017 · Osteoporosis

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una paciente que se realiza una densitometría ósea con T score de -2,7 en las vértebras lumbares y -2,9 en la cadera izquierda?

A) Bifosfonatos
B) Calcitriol
C) Vitamina D
D) Calcio
E) Raloxifeno

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Bifosfonatos** (opción **A**). Tiene osteoporosis: T score menor a -2,5.. Alternativas: denosumab si contraindicados todos los bifosfonatos; anabólicos si fracturas pese a tratamiento De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 173 1.11.1.017 · Osteoporosis

Paciente femenina con artritis reumatoide, en tratamiento con metrotexate y prednisona desde hace 4 años, es diagnosticada de diabetes mellitus, por lo que se inicia metformina como tratamiento. ¿Que examen es perentorio realizarle, como seguimiento a esta paciente?

A) Hemograma, con recuento de plaquetas
B) Radiografía atlantoaxoidea
C) Insulinemia
D) LDH
E) Densitometría ósea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Todo paciente con tratamiento corticoidal debe hacerse densitometrías óseas, porque se produce osteoporosis secundaria. Si bien la artritis reumatoide (AR) aumenta el riesgo de daño de la articulación atlantoaxoidea, no es necesario hacer la radiografía de rutina.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 116 · 1.11.1.017 Osteoporosis

Una paciente de 66 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -3,5 DS en cadera izquierda y -2,8 en la columna lumbar a la altura de la vértebra L4. Trae además una glicemia, un perfil bioquímico y perfil lipídico, todos dentro de rangos normales. Mide 1,68 metros y pesa 49 kilos, ¿Cuál es la conducta más adecuada para esta paciente?

A) Indicar calcio y vitamina D vía oral
B) Indicar una carga de vitamina D vía oral
C) Administrar calcitonina intranasal
D) Indicar bifosfonatos vía oral o endovenosa
E) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos más progestágenos por vía oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por tener una osteoporosis (T score menor o igual a -2,5) se debe tratar con bifosfonatos. Sin embargo, también se debe dar calcio y vitamina D e indicar ejercicios. Asumimos que se pregunta la diferencia entre osteopenia y osteoporosis.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 50 · 1.11.1.010 Fibromialgia

Mujer de 52 años presenta un cuadro de astenia, mialgias y artralgias generalizadas, con debilidad de las extremidades superiores. Refiere que despierta muy cansada, con dolores generalizados que limitan su actividad. Al examen físico presenta movilidad articular normal, con fuerzas conservadas, sin alteraciones sensitivas, ni artritis, pero con dolor a la palpación muscular en múltiples zonas. En sus exámenes presenta hemograma normal, VHS: 12 mm/h, PCR: 0,2 mg/dl, anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, factor reumatoide: 26 UI/ml (VN: < 15 UI/mL) y anticuerpos anti-CCP: 13 UI/L (VN: < 8 UI/L). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar biopsia muscular
B) Indicar pregabalina y ejercicios de estiramiento muscular
C) Iniciar prednisona oral
D) Solicitar perfil ENA (antígenos nucleares extractables)
E) Iniciar metotrexato oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El cuadro clínico es una fibromialgia y los marcadores algo elevados no tienen mayor relevancia (recordar que son una trampa).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 179 · 1.11.1.010 Fibromialgia

Mujer de 54 años, con antecedente de síndrome de intestino irritable, que presenta un cuadro de astenia, debilidad de las extremidades superiores y mialgias. Además refiere sequedad ocular y cefalea. Al examen físico presenta movilidad articular normal, sin alteraciones de la sensibilidad, ni paresias evidentes. Presenta dolor a la presión de ambos epicóndilos y a la palpación de los músculos de la espalda. En sus exámenes presenta hemograma normal, con anticuerpos antinucleares positivos, en titulación 1/40, con factor reumatoide negativo y anticuerpos contra antígenos nucleares extractables negativos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar hidrocortisona endovenosa y reevaluar en una semana
B) Indicar pregabalina y ejercicios suaves de elongación
C) Iniciar prednisona oral
D) Solicitar biopsia de glándula salival secundaria
E) Iniciar metotrexato y antiinflamatorios no esteroidales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Era una fibromialgia (mialgias, astenia y dolor a la compresión de las masas musculares, sin otras alteraciones), probablemente en contexto de un trastorno de somatización. El tratamiento es con ejercicios y estabilizadores de la conducción nerviosa. Que los ANA estén positivos, no importa, porque no hay clínica de lupus. Además, están en una titulación baja (1/40), lo que se encuentra hasta en un 5% de la población sana.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 43 · 1.11.1.025 Vasculitis sistémicas

Un paciente de 75 añosconsulta por cefalea de 2 semanas de evolución, holocránea, intensa, que ha ido en aumento. En el último tiempo refiere además dolor al tocarse el cuero cabelludo y dolor en la rodilla derecha. Al examen físico se constatan signos de derrame articular de la rodilla derecha. Se realiza exámenes, entre los que figura un hemograma, con hemoglobina: 12,0 g/dl, blancos: 9.600 por mm3 y VHS: 76 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis seronegativa
B) Arteritis de células gigantes
C) Artritis reactiva
D) Lupus
E) Endocarditis aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Arteritis de células gigantes** (opción **B**). Es una arteritis de la temporal o de células gigantes clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 157 · 1.11.1.025 Vasculitis sistémicas

Una paciente de 65 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de aste- nia y debilidad de las cuatro extremidades, asociada mialgias. Al examen físico presen- ta dolor a la palpación de los músculos trapecios y supraespinosos y de la región trocan- térica. En sus exámenes destaca CK: 125 UI/L, y hemograma con VHS: 65 mmHg. El diag- nóstico más probable es:

A) Fibromialgia
B) Artritis reumatoide
C) Polimiositis
D) Polimialgia reumática
E) Vasculitis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien parecía a simple vista una fibromialgia, la edad, la VHS alta y las Ck eleva- das hacen sospechar una plomialgia reumática.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 106 · 1.11.1.025 · Vasculitis sistémicas

Una paciente de 76 años presenta, desde hace un mes tos, disnea y expectoración, que en ocasiones es hemoptoica. A lo anterior se agrega hematuria, orinas espumosas, edema de extremidades inferiores y malestar general. En sus exámenes destaca creatinina: 4,6 mg/dl, BUN: 89 mg/dl, K: 5,9 mEq/L, Na: 130 mEq/L, proteinuria: 1.600 mg/24 horas, ANA negativos y complemento normal. El diagnóstico más probable es:

A) Glomerulonefritis postestreptocócica
B) Lupus eritematoso sistémico
C) Tuberculosis miliar
D) Vasculitis sistémica
E) Púrpura trombocitopénico trombótico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome riñón-pulmón, con una alveolitis hemorrágica y una GNRP, que, por la edad, corresponde probablemente a una PAM (poliangeítis microscópica), que es una vasculitis primaria muy agresiva, clásica de los adultos mayores y que se presenta con esta clínica, más mononeuritis múltiple, rash y fiebre, además de síntomas inespecíficos, como malestar y artralgias. Es muy grave y requiere de corticoides e inmunosupresores.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 165 · 1.11.1.025 · Vasculitis sistémicas

Paciente de 18 años con púrpura palpable (no trombocotipémico??) que no desaparece a la digitopresión: a. Purpura henoch schonlein

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta clase introduce el concepto de púrpura en medicina. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 31 · 1.11.1.009 · Esclerosis sistémica progr

Una paciente de 47 años, con antecedente de pirosis y dolor epigástrico de 8 meses de evolución, consulta por disfagia ilógica, de localización alta, que ha ido en aumento. Refiere fenómeno de Raynaud y al examen físico se aprecia esclerodactilia, telangiectasias en el pecho y piel de la cara indurada, sin líneas de expresión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acalasia esofágica
B) Esclerosis sistémica
C) Dermatomiositis
D) Lupus eritematoso sistémico
E) Enfermedad mixta del tejido conectivo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome de CREST clásico (Solo falta la calcinosis, pero tiene Raynaud, Esofagopatía, eSclerodactilia y Telangiectasias, más la Tirantez e la cara).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 45 · 1.11.1.009 · Esclerosis sistémica progr

Una paciente de 50 años, con antecedente de fenómeno de Raynaud frecuente, desde hace 5 años consulta por edema de los dedos y artritis de algunas articulaciones interfalángicas. Se solicitan exámenes inmunológicos que resultan ANA: positivos 1/320, en patrón anticentrómero; antiDNA: negativos; Anti Sm: negativos; Anti Ro negativo; Anti La: negativo; Factor reumatoide: negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis psoriática
B) Esclerosis sistémica
C) Lupus
D) Enfermedad mixta del tejido conectivo
E) Artritis reumatoide

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Esclerosis sistémica** (opción **B**). Es un CREST clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 16 · 1.11.1.009 · Esclerosis sistémica progr

Una paciente de 47 años consulta por pirosis y regurgitación de dos años de evolución, asociada a disfagia alta intermitente, que ha ido en aumento. Al examen físico, presenta signos vitales normales, se observan telangiectasias en el tórax y esclerosis de la piel de los dedos. Su examen cardiopulmonar y abdominal es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acalasia esofágica
B) Esclerosis sistémica progresiva
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Dermatomiositis
E) Polimiositis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Esclerosis Sistémica Progresiva (Síndrome de CREST): Este síndrome se caracteriza por calcinosis, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasias. A largo plazo, puede desarrollar hipertensión pulmonar. El compromiso esofágico suele presentarse como disfagia ilógica y pirosis.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 96 · 1.11.1.007 · Condrocalcinosis

Paciente con varios episodios de artritis de rodilla; punción muestra cristales de pirofosfato de calcio intracelulares. ¿Tratamiento para prevenir nuevas crisis?

A) AINES a demanda
B) Alopurinol
C) Metotrexato oral semanal
D) Infiltración con corticoides
E) Colchicina profiláctica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Colchicina profiláctica** (opción **E**). Colchicina profiláctica. Tratamiento agudo de gota: corticoides (recomendación internacional), AINEs (más usado en Chile) o colchicina en dosis bajas De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 64 · 1.11.1.007 · Condrocalcinosis

Un paciente de 81 años presenta dolor muy intenso den la rodilla derecha, con EVA 8/10, que le impide caminar. En su examen físico, se aprecia eritema y aumento de volumen de la rodilla. Se solicita radiografía de rodilla, que se muestra más abajo. Además, se realiza punción articular, que da salida a un líquido sinovial, con 160.000 glóbulos blancos por mm3, sin visualización de bacterias y con presencia de cristales con elongación positiva débil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis séptica
B) Artritis por cristales de pirofosfato de calcio
C) Artritis por cristales de hidroxiapatita de calcio
D) Artritis por oxalato de calcio
E) Gota

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una condrocalcinosis clásica tanto por la clínica como por la radiografía (meniscos calcificados). El líquido está muy inflamatorio y sugiere infección, pero dice que "no se visualizan bacterias" y, además, la CC puede presentarse, a veces, con más de 100.000 GB/mm3. Es causada por cristales de pirofosfato de calcio.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 132 · 1.11.1.007 · Condrocalcinosis

Un paciente de 70 años ha presentado 3 episodios de dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha, que le impide o dificulta la marcha, pero que ha respondido a analgésicos. Acude nuevamente por los mismos síntomas, objetivándose artritis de rodilla derecha, con signos de derrame articular, por lo que se punciona, dando salida a un líquido articular inflamatorio, con abundantes cristales de pirofosfato de calcio, sin bacterias. ¿Qué fármaco es más adecuado para evitar recurrencias?

A) Colchicina
B) Naproxeno
C) Alopurinol
D) Hidroclorotiazida
E) Metotrexato

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La opción correcta es la **A** (Colchicina). En este escenario clínico, colchicina se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 2 · 1.11.1.007 · Condrocalcinosis

Un paciente de 75 años, es hospitalizado hace 2 días, por un accidente vascular ence- fálico. Presenta dolor, eritema y aumento de volumen de la rodilla izquierda, con impo- tencia funcional. Al examen se aprecia eritema y signos de derrame articular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artritis séptica
B) Artritis por cristales
C) Artritis reactiva
D) Artritis reumatoide
E) Osteoartritis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La condrocalcinosis es la causa más frecuente de monoartritis aguda en el adulto mayor y suele desencadenarse por reposo, como este caso.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 28 · 1.11.1.014 · Lupus eritematoso sistémic

Una mujer de 30 años presenta un cuadro de malestar general y artralgias de varias semanas de evolución, asociada a febrícula ocasional. Al examen físico se aprecia rash facial, úlceras orales, alopecia difusa, artritis de varias articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de ambas manos. Se solicitan exámenes, entre los que se encuentran hemograma con hematocrito: 30%, hemoglobina: 10 g/dl, leucocitos: 4.000 por mm3, con 15% de linfocitos, además se solicitan ANA (+) en dilución 1:640, Anti-DNA de 2 hebras (+) en dilución 1:160, C3: 60 mg/dl, C4:11 mg/dl, factor reumatoide: 65 U/ml y Anti-CCP (-). El diagnóstico más probable es:

A) Artritis reumatoide
B) Púrpura trombocitopénico trombótico
C) Lupus eritematoso sistémico
D) Vasculitis
E) Dermatomiositis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene muchas cosas de lupus sistémico: úlceras orales, rash malar, linfocitos bajo, ANA+, anti-DNA+, hipocomplementemia.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 74 · 1.11.1.014 · Lupus eritematoso sistémic

Una paciente de 28 años, consulta por artralgias generalizadas, asociadas a sensa- ción febril y úlceras orales. En sus exámenes destaca creatinina: 1,5 mg/dl, sedimento de orina con hematuria y cilindros hemáticos y hemograma con 4.000 blancos por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Solicitar factor reumatoide
B) Solicitar radiografía de tórax
C) Solicitar PCR, VHS y creatinfosfoquinasa
D) Solicitar anticuerpos antinucleares
E) Solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar anticuerpos antinucleares** (opción **D**). Es un lupus sistémico y la única opción aceptable eran los ANA.. Tratamiento estable: hidroxicloroquina + prednisona + ahorradores de corticoides De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 154 · 1.11.1.014 · Lupus eritematoso sistémic

Paciente con síndrome nefrótico e hipergammaglobulinemia policlonal, complemento bajo. Diagnóstico:

A) Lupus
B) Amiloidosis
C) Mieloma múltiple
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Lupus** (opción **A**). El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad del tejido conectivo ANA positiva potencialmente grave. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 98 1.11.1.014 · Lupus eritematoso sistémic

Una paciente de 23 años presenta aparición súbita de lesiones eritematosas en las mejillas, que iniciaron luego de exponerse al sol y se asocian a malestar general, caída de cabello y artralgias de manos. En el examen físico destaca eritema malar y edema de extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran hemograma con hemoglobina: 9,8 g/dl, hematocrito 29%, glóbulos blancos: 3500 por mm3 y plaquetas: 90.000 por mm3, más examen de orina con proteinuria +++ y hematuria. ¿Cuál es el examen más sensible para el diagnóstico de la patología descrita?

A) Factor reumatoide
B) Anticuerpos anti-Ro
C) Anticuerpos anti-Sm
D) Anticuerpos antinucleares
E) Anticuerpos antifosfolípidos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un lupus eritematoso sistémico. El examen más sensible son los ANA (S = 95%). Los más específicos son los anti-DNA 2h (E = 95%, pero S = 50%; además son indicador de mal pronóstico y de actividad) y los anti-Sm (E = 99%, pero S = 25%).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 104 1.11.1.020 · Polimiositis, dermatomiosi

Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas de 2 semanas de evolución, mayores en los muslos, asociadas a debilidad, mayor en la cintura pélvica y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Al examen físico se objetiva debilidad muscular de predominio proximal, sin alteraciones sensitivas. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 37%, blancos: 7.000 por mm3, plaquetas: 250.000 por mm3, VHS: 10 mm/hora. Además, trae glicemia: 150 mg/dl, creatinfosfoquinasa: 1.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L, SGOT: 250 UI/L, SGPT: 170 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polimiositis
B) Polimialgia reumática
C) Polineuropatía diabética
D) Miopatía por cuerpos de inclusión
E) Síndrome de Guillain Barré

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La debilidad proximal orienta a miopatía. La elevación de la CK y de los parámetros inflamatorios (PCR) orienta a polimiositis. La polimialgia reumática también puede tener una clínica similar e incluso elevar las CK, pero tiende a elevar mucho la VHS (la polimiositis también puede hacerlo) y, lo más importante, no tiene debilidad en el examen físico (aunque sí puede tener sensación de debilidad). La miopatía por cuerpos de inclusión también es una miopatía inflamatoria y puede tener una clínica similar, pero mucho más lenta (de años o varios meses) y suele afectar muslos y antebrazos con más frecuencia (afectación proximal y distal). Revisar semiología neurológica para las otras opciones.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 105 1.11.1.020 · Polimiositis, dermatomiosi

Un paciente de 71 años, con antecedente de diabetes, hipertensión arterial y lumbago crónico, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, atorvastatina y losartán, presenta un cuadro de 1 mes de debilidad de las 4 extremidades, mayor en los muslos, asociadas a mialgias, que en el último tiempo le han dificultado la marcha. Al examen físico se constata paresia M4 de ambas extremidades inferiores, mayor en los cuádriceps, sin alteraciones sensitivas ni focalidad neurológica. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina: 12,1 g/dl, hematocrito: 33%, blancos: 6.200 por mm3, plaquetas: 180.000 por mm3, VHS: 50 mm/hora, SGOT: 210 UI/L, SGPT: 110 UI/L, CPK: 3.760 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 mg/L y hemoglobina glicosilada: 7,5%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miopatía por estatinas
B) Polimialgia reumática
C) Polimiositis
D) Miositis por cuerpos de inclusión
E) Raquiestenosis medular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Polimiositis** (opción **C**). Es otra polimiositis clásica, en especial por el marcado aumento de las CPK y la debilidad.. La polimiositis y dermatomiositis son miopatías autoinmunes. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 104 1.11.1.020 · Polimiositis, dermatomiosi

Una paciente de 58 años, con antecedente de cáncer de mama, tratado con cirugía y radioterapia hace un año, consulta astenia y debilidad de las 4 extremidades. Al exa- men físico presenta edema y eritema palpebral, asociado a aumento de volumen en el brazo derecho. Al examen neurológico se constata la tetraparesia, con reflejos osteoten- díneos normales, sin alteraciones en el tono muscular, ni signos focales. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Miastenia gravis
C) Polimialgia reumática
D) Dermatomiosistis
E) Vasculitis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una dermatomiositis clásica: compromiso de párpados, mialgias, debilidad. Re- cordar que suele ser paraneoplásica, por lo que además se debe sospechar recidiva del cáncer.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 131 1.11.1.020 · Polimiositis, dermatomiosi

Un hombre de 78 años consulta por debilidad de las extremidades inferiores, que le dificulta realizar movimientos como pararse de una silla o subir escaleras. Al examen físico tiene paresia de las extremidades inferiores, la sensibilidad es normal y no tiene alteración de los reflejos osteotendíneos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polimiositis
B) Hipotiroidismo
C) Déficit de vitamina B12
D) Distrofia muscular progresiva
E) Raquiestenosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene clínica de una miopatía: debilidad proximal, sin alteraciones sensitivas ni de los reflejos. B, C y E afectan los reflejos y tienen otros síntomas. La raquiestenosis principalmente tiene dolor al caminar, más afectación de las raíces comprometidas. D afecta más a niños, ya que es genética.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 118 · 1.11.1.020 · Polimiositis, dermatomiosi

Un hombre de 68 años, diabético mal controlado, consulta por mialgias generalizadas, asociadas a debilidad, mayor en la cintura escapular y astenia. En el último tiempo refiere dificultades para ponerse de pie, desde una silla o desde la cama. Se solicitan exámenes, entre los que destacan CK: 1.800 UI/L, LDH: 1.050 UI/L, PCR: 4,3 (VN: menor a 1). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polimiositis
B) Polimialgia reumática
C) Polineuropatía diabética
D) Miopatía por cuerpos de inclusión
E) Dermatomiositis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

[Pregunta disputada] Por la edad, lo más probable es la polimialgia reumática, aunque generalmente no eleva tanto las CK y suele cursar sin debilidad, sino solo con las mialgias. Por otro lado, tanto polimiositis (PM), como la miositis por cuerpos de inclusión (MCI) calzan con el cuadro y las alteraciones, aunque la MCI tiene atrofia de cuádriceps y del antebrazo, como cosa característica (pero es más frecuente a esa edad que la PM). No sé cual es la respuesta correcta (esperemos que se elimine).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 109 · 1.11.1.020 · Polimiositis, dermatomiosi

Un paciente de 82 años, con antecedente de diabetes y enfermedad coronaria, en tratamiento farmacológico con metformina 1 gramo cada 8 horas, glibenclamida 10 mg cada 12 horas, aspirina 100 mg al día y atorvastatina 40 mg al día, presenta un cuadro de mialgias generalizadas, asociadas a debilidad muscular, mayor en la cintura escapular y los muslos. Se solicitan exámenes, entre los que destacan CK: 1.320 UI/L, GOT: 128 UI/L y GOT: 133 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Miopatía diabética
B) Polineuropatía diabética
C) Miopatía por estatinas
D) Polimiositis
E) Polimialgia reumática

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Miopatía por estatinas** (opción **C**). Es una miopatía pos estatinas clásica.. La polimiositis y dermatomiositis son miopatías autoinmunes. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 29 · 1.11.1.001 · Artritis psoriática

Una paciente de 42 años presenta artritis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales de ambas manos, con afectaciónreciente de una articulación metatarsofalángica. Al examen físico, además de las artritis descritas, presenta múltiples depresiones en las uñas de las manos y engrosamiento de las uñas de los pies. ¿A qué tipo de artritis corresponde este cuadro?

A) Reumatoide
B) Reactiva
C) Psoriática
D) Gotosa
E) Lúpica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Psoriática). Es una artritis psoriática clásica (con los picotazos ungueales).. La artritis psoriásica es una pelvispondiloartropatía asociada a psoriasis. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 111 · 1.11.1.001 · Artritis psoriática

Una paciente de 40 años presenta artri8s de muñecas y de ar8culaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales de ambas manos, de 6 semanas de evolución. Recientemente se agregó dolor y aumento de volumen generalizado del segundo ortejo derecho, que le dificulta la marcha. Al examen Fsico se aprecia aumento de volumen y eritema de las ar8culaciones descritas, más lesiones deprimidas pun8formes en las uñas de las manos, con engrosamiento de las uñas de los pies. El cuadro descrito corresponde a una artri8s de 8po:

A) Reumatoide
B) Infecciosa
C) Reac2va
D) Psoriá2ca
E) Gotosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una artriGs psoriática clásica, con dacGliGs (“dedos en salchicha”) y lesiones ungueales (“en picotazo de pájaro).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 129 · 1.11.1.001 · Artritis psoriática

Un paciente de 30 años presenta lumbago de 6 meses de evolución, intenso, que limita sus actividades y que es más molesto en la mañana y va cediendo durante el día. Al examen físico tiene lesiones descamativas en las rodillas y punteado ungueal y el examen de la columna muestra limitación a la flexión, con test de Schöber modificado de 2 cm. Se solicitan exámenes que muestran VHS: 60 mm/h, PCR: 5,0 mg/dl, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide negativos. ¿Cuál es el examen de elección para establecer el diagnóstico en este paciente?

A) Radiografía de columna lumbosacra
B) Radiografía de columna dorsolumbar
C) TAC de columna lumbosacra
D) Resonancia magnética de columna dorsolumbar
E) Resonancia magnética de articulaciones sacroilíacas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una artritis psoriática clásica, con la pelviespondiloartropatía, que se estudia con RMN de sacroilíacas, como el mejor examen, considerado de elección actualmente (por eso la dejamos como correcta), aunque se suele iniciar con la Rx de sacroilíacas.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 69 · 1.11.1.015 · Monoartritis

Un paciente de 78 años consulta por gonalgia derecha intensa, que impide la marcha, asociada a aumento de volumen. Al examen físico presenta edema, eritema y aumento de la temperatura local, con signos de derrame articular. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar antibióticos endovenosos
B) Solicitar factor reumatoide, ANA y ácido úrico
C) Iniciar AINEs
D) Realizar artrocentesis diagnóstica
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de rodilla

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una monoartritis aguda, que se estudia con punción. Por clínica, probablemente será una condrocalcinosis, pero también puede ser una artritis séptica, por lo que es fundamental la punción.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 112 1.11.1.015 · Monoartritis

Un paciente de 60 años consulta por dolor de la rodilla derecha, de 24 horas de evolución, que ha aumentado rápidamente en intensidad, dificultándole caminar. Sus signos vitales muestran temperatura: 37,2 °C, frecuencia cardíaca: 69 la8dos por minuto y presión arterial: 135/75 mmHg. Al examen de las extremidades se observa rodilla aumentada de volumen, con signos de derrame ar8cular, sin eritema ni aumento de la temperatura local. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de rodilla
B) Solicitar ecogra:a de rodilla
C) Iniciar alopurinol vía oral
D) Realizar punción ar2cular y estudio de líquido sinovial
E) Solicitar factor reumatoide y an2cuerpos an2nucleares

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una monoatriGs aguda, por lo que se debe estudiar con artrocentesis y estudio de líquido sinovial, que diferencia entre artriGs séptica, artriGs por cristales y artrosis. El cuadro clínico sugiere una condrocalcinosis.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 126 1.11.1.022 · Síndrome de Sjögren

Una paciente de 43 años presenta sequedad bucal, asociada a ardor y sensación de arenilla ocular y a artralgias. Al examen físico tiene sequedad de piel y de mucosas, se observa aumento de volumen de ambas parótidas y se palpan adenopatías submandibulares de consistencia aumentada. Se solicitan exámenes, que muestra FR: 40 UI/nl, ANA positivos 1/16, ENA negativo, antiDNA negativo. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio diagnóstico?

A) Punción parotidea
B) Biopsia ganglionar
C) Anticuerpos anti-CCP
D) Biopsia de glándula salival accesoria
E) Anticuerpos anti-Sm

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La historia es compatible con un síndrome de Sjögren (tiene el síndrome de Sicca: xeroftalmia y xerostomía). El 90% tiene FR positivo. Además, es frecuente que tengan positivos los ANA, con un perfil ENA que muestra anticuerpos anti-Ro o anti-La positivos. Se confirma la biopsia de glándula salival menor o con los anticuerpos anti-Ro o anti-La, aunque actualmente el diagnóstico se realiza en base a una serie de criterios clínicos y de laboratorio, que no vale la pena aprenderse.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 149 1.11.1.021 · Síndrome antifosfolípidos

Mujer joven, aborto hace 3 meses, tiene anemia, hace una TVP confirmada por eco doppler, estudio etiológico:

A) SAF
B) Estudio Lupus
C) Pedir antitrombina III
D) Estudio TVP??
E) Hemograma y VHS

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (SAF). El síndrome antifosfolípido (SAF) es una trombofilia adquirida que puede ser primario o secundario (principalmente a lupus). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

NEUROLOGÍA & GERIATRÍA

Módulo 1: Medicina Interna · Colección Tomo 10

82 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

29 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.10.1.001	Cefalea tensional	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 09 · 9.7 (Pág. 26)
1.10.1.003	Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.005	Demencia (Enfermedad de Alzheimer,	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 10 · 10.14 (Pág. 51)
1.10.1.006	Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 10 · 10.11 (Pág. 43)
1.10.1.007	Epilepsia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 10 · 10.8 (Pág. 30)
1.10.1.008	Esclerosis múltiple	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 10 · 10.18 (Pág. 68)
1.10.1.009	Herpes zoster	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 10 · C.5 (Pág. 14)
1.10.1.013	Neuralgia esencial del trigémino	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 10 · 10.7 (Pág. 28)
1.10.1.014	Neuropatías por atrapamiento	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 10 · C.7 (Pág. 18)
1.10.1.015	Parálisis (tetraparesia, hemiparesia, etc)	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 10 · C.11 (Pág. 26)
1.10.1.017	Polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías, etc...	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.018	Síndrome atáxico	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.019	Síndrome de hipertensión endocraneana	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.020	Síndrome miasténico	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · 10.17 (Pág. 64)
1.10.1.024	Síndromes vertiginosos centrales	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.026	Temblor esencial	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 10 · 10.13 (Pág. 49)
1.10.1.027	Trastornos del sueño	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.028	Tumores de región sellar	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.1.029	Tumores primarios y metastásicos SNC	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.003	Crisis convulsiva	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · 10.3 (Pág. 11)
1.10.2.006	Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.12 (Pág. 49)
1.10.2.007	Enfermedad cerebrovascular	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	14 Q	Tomo 10 · 10.1 (Pág. 5)
1.10.2.008	Hemorragia subaracnoídea	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 10 · 10.4 (Pág. 15)
1.10.2.013	Síndrome cuadriparético fláccido	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 10 · 10.16 (Pág. 60)
1.10.2.014	Síndrome encefalítico (Herpes Simplex)	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.2.015	Síndromes convulsivos sintomáticos (traumático,	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · 10.10 (Pág. 38)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.10.2.021	Traumatismo encefalocraneano grave	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.3.002	Prevención de factores de riesgo cerebrovascular	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)
1.10.4.006	Electromiografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 10 · Neurología (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 93 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para hablar. Al examen físico tiene hemiparesia faciobraquiocrural derecha y afasia. Su TAC de cerebro es normal. La conducta más adecuada es:

A) Anticoagular con heparina
B) Administrar antiagregantes plaquetarios
C) Solicitar resonancia magnética nuclear
D) Realizar embolectomía
E) Realizar trombólisis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un AVE diagnosticado (se diagnostica con la clínica de signos focales de inicio súbito). La TAC se pide solo para diferenciar los AVE hemorrágicos, de los isquémicos y, en este caso, por estar normal la TAC se confirma que no es hemorrágico, sino isquémico. Por tener menos de 4,5 horas de evolución, está dentro de la ventana de trombolíticos, que es lo más urgente (rTPA ev).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 66 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Paciente de 72 años llega a urgencias con hemiparesia derecha y afasia de inicio súbito hace 5 horas. TAC de cerebro sin contraste: normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antiagregación plaquetaria (aspirina 250 mg) e hospitalización
B) Trombolizar con rtPA (ya pasaron >4.5h, fuera de ventana)
C) Trombectomía mecánica (evaluar si hay oclusión de gran vaso)
D) Observación domiciliaria
E) Anticoagulación con heparina inmediata

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

ACV isquémico a las 5 horas: fuera de ventana para trombolisis (>4.5h). Si no hay oclusión de gran vaso, el tratamiento es antiagregación (aspirina) + hospitalización para monitoreo y estudios etiológicos. Anticoagulación no está indicada en ACV isquémico agudo de forma rutinaria.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 76 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Un paciente de 32 años presenta dolor cervical intenso, mientras realizaba deporte, que se irradia hacia la cara, zona temporal y se asocia a cefalea intensa. Al examen físico se observa ptosis y miosis derechas. El diagnóstico más probable es:

A) Parálisis del tercer nervio craneal
B) Aneurisma cerebral anterior, con compromiso del tercer nervio craneal
C) Infarto vertebrobasilar
D) Migraña hemipléjica
E) Disección carotidea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La disección carotídea suele darse en contexto de deportes de contacto o ejercicios de elongación y su clínica es dolor cervical y cefalea. Además, en este caso, se produjo un síndrome de Horner, por compresión del ganglio estrellado, a nivel de la bifurcación carotídea.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 119 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Una paciente de 24 refiere que luego de realizar ejercicios de elongación, presenta dolor súbito en el cuello y en la cabeza, con cefalea en trueno (thunderclap). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cefalea cluster o en racimo
B) Accidente isquémico transitorio
C) Disección de la arteria cerebral o carótida
D) Migraña sin aura desencadenada por el ejercicio.
E) Hernia traumática del núcleo pulposo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Disección de la arteria cerebral o carótida** (opción **C**). La disección era la única opción posible. Sigue siendo un cuadro raro.. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 26 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Un paciente de 60 años, con hipertensión arterial de larga data mal controlada, consulta por cefalea intensa que ha aumentado en intensidad hasta EVA 9/10, asociada a vómitos y mareos de 2 horas de evolución, por lo que acude al servicio de urgencias. Al examen Fsico presenta presión arterial 170/105 mmHg y frecuencia cardíaca 62 lpm, sin signos focales en el examen neurológico. Se solicita una TAC de cerebro que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hematoma subdural
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Infarto de arteria cerebral media con transformación hemorrágica
D) Hematoma talámico derecho
E) Hemorragia intraparenquimatosa secundaria a malformación arteriovenosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sangre se ve blanca en la TAC. Es un hematoma intraparenquimatoso de localización talámica. El diagnóstico, por tanto, es un ACV hemorrágico, que contraindica la aspirina, anticoagulación y trombólisis y se debe manejar con medidas de neuroprotección con objetivo de PA sistólica cercana a 140 mmHg (si está sobre 220 mmHg, se debe bajar rápido, pero no tanto); en el isquémico, en cambio, se baja la PA para que sea menor a 220/120 mmHg. Fuente imagen: Revista Seram 34.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 97 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Una paciente de 65 años, hipertenso y diabético de larga data, consulta por cefalea intensa de inicio súbito, asociado a dificultades para moverse. Al examen físico tiene una hemiparesia derecha, armónica, sin compromiso de conciencia y con conservación del lenguaje y la sensibilidad. No tiene alteraciones visuales. Como antecedente, ha sufrido golpes por caídas a repetición. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media
B) Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral anterior
C) Hemorragia de la protuberancia anular o puente de Varolio
D) Accidente vascular encefálico hemorrágico
E) Accidente vascular de tipo lacunar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Accidente vascular encefálico por compromiso de la arteria cerebral media** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 121 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Paciente con cefalea súbita y hemiplejia del hemicuerpo izquierdo, sin alteraciones sensitivas ni del habla. ¿Diagnóstico más probable?

A) Hemorragia intracerebral en cápsula interna
B) AVE isquémico de territorio carotídeo
C) Hematoma subdural agudo
D) AVE isquémico de territorio basilar
E) Infarto lacunar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Infarto lacunar** (opción **E**). Infarto lacunar. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 1 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Una paciente de 40 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cefalea holocránea, muy intensa, de 5 días de evolución, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, mayores en la mañana, y que no ha respondido al uso de analgésicos orales. Hoy presentó una convulsión tónico-clónica. En su examen físico tiene sopor superficial paresia de las extremidades derechas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Migraña por anticonceptivos
B) Infarto cerebral extenso
C) Accidente vascular lacunar
D) Epilepsia con parálisis de Todd
E) Trombosis venosa cerebral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta difícil, pero tiene una cefalea con signos de HTEC y signos focales, más convulsiones. Orienta a trombosis de seno cavernoso el antecedente de ACO. También podría haber sido un tumor cerebral, aunque con una evolución más lenta. La migraña sería crónica.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 144 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Paciente con dolor cervical súbito derecho con irradiación a hemicráneo ipsilateral tras ejercicio, más ptosis y miosis. ¿Diagnóstico más probable?

A) Neuralgia del trigémino (rama V1)
B) Migraña con aura
C) Cefalea en racimos (cluster)
D) Disección de arteria carótida interna derecha
E) Síndrome de Horner idiopático

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Disección de arteria carótida interna derecha** (opción **D**). Disección de arteria carótida interna derecha. La combinación cardinal de dolor torácico súbito desgarrador (EVA 10/10) irradiado a región interescapular o dorso, cifras tensionales severas y asimetría de pulsos periféricos en extremidades superiores es patognomónica de disección aórtica aguda. Requiere angio-TAC de tórax inmediato y estabilización hemodinámica con betabloqueadores EV para reducir la fuerza de eyección ventricular (dP/dt).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 24 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Un paciente de, con antecedente de hipertensión arterial crónica y caídas, consulta por cefalea de instalación brusca, hace algunas horas, asociado a imposibilidad de mover las extremidades derechas. Al examen neurológico presenta hemiplejia armónica derecha, sin alteraciones sensitivas, del habla ni del estado de conciencia. El diagnóstico más probable es:

A) Hematoma subdural
B) Accidente vascular encefálico lacunar
C) Accidente de la arteria cerebral media izquierda
D) Accidente vascular hemorrágico del puente
E) Hemorragia subaracnoidea

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En la práctica no es fácil diferenciar los distitos tipos de AVE con la sola clínica. La cefalea orienta más a hemorrágico, pero en el puente, habría tenido compromiso de conciencia y afectación de pares craneanos. El de arteria cerebral media tendría alteraciones del habla y sensitivas. Una AVE lacunar clásico es el con hemiparesia pura, sin afectación del habla ni conciencia. Suelen no tener cefalea, pero el 10% sí tiene.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 84 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Un paciente de 62 años presenta tendencia a la somnolencia, asociado a dificultad para realizar movimientos con la mitad derecha del cuerpo, que inició hace 2 horas. Al examen físico se aprecia un paciente confuso con una hemiparesia braquicrural dere- cha, parálisis del tercer par izquierdo y signo de Babinski bilateral. ¿Cuál es el diagnós- tico más probable?

A) Infarto de arteria cerebral media derecha
B) Infarto de arteria cerebral media izquierda
C) Infarto de tronco-encéfalo
D) Síndrome de enclavamiento
E) Infarto vertebro-basilar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
C, D? Si bien parece un síndrome alterno clásico (compromiso de un par craneal, más hemiparesia contralateral), es probable que se trate de un infarto de troncoencéfa- lo. Sin embargo, la clínica del enclavamiento transtentorial es casi idéntica. No es posi- ble hacer la distinción con el enunciado. Es una mala pregunta.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 28 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Un paciente de 51 años, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión en tratamiento, es traído por presentar cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural izquierda de inicio súbito desde hace 2 horas, asociado a dificultad para articular palabras. Al examen físico se corrobora dicha paresia asociada a disminución de reflejos en lado izquierdo. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Punción lumbar
B) Resonancia magnética
C) TAC de cerebro con contraste
D) TAC de cerebro sin contraste e) Angiografía de arteria cerebral media
E) Hemograma y VHS

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la RMN es el mejor examen (da más información), el TAC sin contraste es el de elección, ya que es más rápido (la RMN demora 45 min o más y cada minuto es vital en el AVE) y permite diferenciar el AVE isquémico del hemorrágico, que es lo que importa para determinar el manejo en este momento, ya que al llevar 2 horas, está en la ventana para trombolisis intravenosa con rTPA (hasta 4,5 horas, aunque su efectividad mayor es durante las primeras 3 horas). Sigue siendo una pregunta discutible, pero yo marcaría TAC. Eso sí, hay que ver cómo está redactada la pregunta en el examen original.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 93 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Un paciente de 35 años presenta dolor cervical súbito, mayor en el lado derecho, que inició mientras hacía deporte. El dolor es intenso y se irradia a la cara. Al examen neurológico, destaca ptosis y miosis del ojo derecho, sin alteraciones de la sensibilidad ni motilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cefalea en racimo (cluster headache)
B) Parálisis del tercer par
C) Disección carotídea
D) Malformación vascular cerebral con compresión del tercer nervio craneal
E) Infarto vertebro basilar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Parálisis del tercer par** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 55 1.10.2.007 · Enfermedad cerebrovascular

Una paciente de 40 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cefalea holocránea, muy intensa, de 5 días de evolución, que se ha asociado a vómitos alimentarios, mayores en la mañana, y que no ha respondido al uso de analgésicos orales. En su examen físico no hay signos neurológicos focales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombosis venosa profunda de seno encefálico
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Infarto lacunar
D) Hematoma intraparenquimatoso
E) Crisis de migraña

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La clínica es compatible con una trombosis de seno cavernoso. Tiene signos de alarma (no es migraña), no tiene signos focales (no es AVE lacunar ni hemorrágico) y lleva 5 días (no es HSA). Por tanto, solo queda marcar la A.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 111 1.10.1.014 · Neuropatías por atrapamien

Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en ambas manos, de predominio nocturno, que disminuyen con el movimiento y ceden al iniciar sus actividades diarias. El examen físico muestra movilidad y sensibilidad conservadas, con leve atrofia de la eminencia tenar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neuropatía diabética simétrica sensitiva
B) Contractura de Dupuytren
C) Atrapamiento de los dedos flexores de la mano
D) Artritis reumatoide
E) Síndrome del túnel carpiano

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome del Túnel Carpiano vs. Neuropatía Diabética: El paciente presenta un cuadro clínico compatible con síndrome del túnel carpiano. Se asocia a diabetes. El dolor nocturno y la desaparición de los síntomas con las actividades de la vida diaria son características distintivas del síndrome del túnel carpiano. En contraste, la neuropatía diabética simétrica sensitiva suele afectar primero a los pies y solo en etapas más avanzadas a las manos.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 30 1.10.1.014 · Neuropatías por atrapamien

Un paciente de 65 años, alcohólico inveterado, se queda dormido sobre el costado derecho, mientras estaba borracho. Al despertar, al día siguiente, no puede mover la mano derecha. Al examen neurológico, no puede extender los dedos ni la muñeca, aunque puede flectarlos sin problemas. Además no tiene alteraciones visuales ni afasia. El diagnóstico más probable es:

A) Hematoma subdural izquierdo
B) Trombosis de la vena subclavia
C) Neuropatía compresiva del nervio radial
D) Trombosis de la arteria subclavia
E) Hematoma capsular izquierdo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una presentación clásica de neuropatía compresiva del nervio radial. De hecho, la llaman la “parálisis del borracho”.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 97 1.10.1.014 · Neuropatías por atrapamien

Paciente con parestesias nocturnas en una mano que ceden al sacudir las manos. ¿Diagnóstico más probable?

A) Neuropatía cubital
B) Síndrome de Raynaud
C) Síndrome del túnel carpiano
D) Radiculopatía C6
E) Polineuropatía diabética

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome del túnel carpiano** (opción **C**). Síndrome del túnel carpiano. Esta clase cubre las cefaleas crónicas: migraña/jaqueca, cefalea tensional, cefalea en racimos (cluster/Horton), neuralgia del trigémino y otras neuralgias. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 126 1.10.1.014 · Neuropatías por atrapamien

Paciente embarazada de 26 semanas, bien controlada, consulta por cuadro de una semana de sensación de hormigueo en ambas manos de predominio nocturno, mayor en lado derecho, sin otros síntomas. Al examen físico destaca parestesia en ambas manos al mantener muñecas flexionadas por 20 segundos. El diagnóstico más probable:

A) Mielopatía cervical
B) Polimiositis
C) Miastenia gravis
D) Atrapamiento del nervio cubital
E) Atrapamiento del nervio mediano

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Atrapamiento del nervio mediano** (opción **E**). Tiene un tunel carpiano. Esta clase cubre las cefaleas crónicas: migraña/jaqueca, cefalea tensional, cefalea en racimos (cluster/Horton), neuralgia del trigémino y otras neuralgias. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 58 1.10.1.014 · Neuropatías por atrapamien

Un paciente de 63 años, diabético mal controlado, presenta parestesias, asociada a dolor en ambas manos, que es mayor en la noche y que se irradia a ambos codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polineuropatía diabética
B) Hernia del núcleo pulposo
C) Síndrome de túnel carpiano
D) Síndrome de atrapamiento cubital
E) Neuropatía radial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

A, C?. Pésima pregunta. Con una clínica tan escasa, se induce a error, ya que no especifican qué sector de las manos son las con parestesias (es lo más importante en este caso). Que se irradie a los codos, hace improbable que sea un túnel carpiano. Que sea bilateral, orienta a una polineuropatía diabetica, pero falta la afectación de los pies.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 6 1.10.1.014 · Neuropatías por atrapamien

Un paciente, luego de un “sueño profundo”, en relación a una intoxicación alcohólica, presenta debilidad y dificultad para tomar objetos con la mano derecha, como sostener una taza, la que se le cae. Al examen físico no tiene alteraciones en la sensibilidad, ni en los reflejos osteotendíneos, los que permanecen conservados. Sin embargo, al solicitarle que ponga los brazos en posición horizontal, se observa que la mano derecha está “caída”. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

A) Lesión del nervio radial
B) Lesión del plexo braquial
C) Lesión de los nervios cubital y mediano
D) Isquemia de los músculos del antebrazo
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es la historia clásica de la neuropatía radial por compresión, del borracho. Igual la dificultad para tomar objetos podría orientar a lesión del plexo braquial.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 178 1.10.2.008 · Hemorragia subaracnoídea

Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha acompañado de vómitos alimentarios. Al examen físico está vigil y orientada, adolorida, con FC: 70x’, PA: 140/90 mmHg, en el examen neurológico tiene signos meníngeos presentes, sin alteraciones motoras ni sensitivas. Se solicita TAC de cerebro sin contraste, que muestra hiperdensidad del espacio intercomisural frontal y del espacio subaracnoideo basal. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Resonancia magnética nuclear de cerebro
B) Punción lumbar
C) TAC de cerebro con contraste
D) Angiografía cerebral
E) Ecocardiograma

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Angiografía cerebral). Tiene una angina crónica estable, por lo que se debe estudiar con un test de La.... Esta clase aborda el enfrentamiento general de las cefaleas, enfatizando la identificación de signos de alarma para diferenciar causas graves de benignas. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 136 1.10.2.008 · Hemorragia subaracnoídea

Un paciente de 50 años, sin antecedentes, presenta cefalea de inicio súbito mientras hacía deporte, asociado a dolor en la zona cervical posterior y dorsal. Al examen físico presenta reflejo fotomotor conservado, signos meníngeos presentes, fuerza y sensibilidad disminuidas en hemicuerpo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Hemorragia subaracnoídea
B) Hematoma epidural
C) Hematoma subdural
D) Hemorragia cerebral intraparenquimatosa
E) Accidente vascular isquémico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Cefalea súbita. La relación con el ejercicio puede orientar. Los signos meníngeos orientan mucho y los signos focales no son característicos, pero pueden aparecer. Si solo fuera cefalea más signos focales, tendería a marcar hematoma intracerebral, pero como está planteada la pregunta, seguro es una HSA. Clave Eplicación

---

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 139 1.10.2.008 · Hemorragia subaracnoídea

Un paciente de 54 años, alcohólico e hipertenso, hace una semana suspende todos los antihipertensivos. Es traído a la urgencia por cefalea muy intensa, de inicio agudo, asociado a desorientación y compromiso de conciencia. Al examen físico está soporoso, no habla ni sigue indicaciones, aunque mantiene movilidad espontánea de las 4 extremidades. Sus reflejos osteotendíneos y tono muscular son normales y tiene signo de Babinski bilateral. El diagnóstico más probable es:

A) Hemorragia subaracnoidea
B) Meningitis bacteriana
C) Edema cerebral
D) Intoxicación etílica
E) Accidente vascular isquémico extenso

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta difícil, pero la cefalea ictal muy intensa sugiere HSA. El compromiso de conciencia también. Ver resumen de semiología neurológica.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 139 · 1.10.2.008 · Hemorragia subaracnoídea

Mujer con cefalea súbita e intensa + signos meníngeos esbozados, con antecedente de pansinusitis cronica y migraña, al control de signos vitales con PA 170/100 ¿Cual es la conducta inicial mas importante? a. TAC de cerebro

B) Control de crisis hipertensiva
B) Accidente cerebrovascular
C) Epilepsia
D) Esclerosis múltiple
E) Enfermedad de Parkinson

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **** (opción **A**). Tratamiento hemorragia subaracnoidea: manejo igual a AVE hemorrágico + neurocirugía para cerrar aneurisma + nimodipino (previene vasoespasmo) por 3 semanas. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 23 · 1.10.2.013 · Síndrome cuadriparético fl

Un paciente de 29 años consulta por un cuadro de 7 días, progresivo, de disminución de la fuerza muscular, tanto en las extremidades superiores, como en las inferiores, siendo mayor en las inferiores. Tiene el antecedente de haber sufrido una influenza hace 14 días. Al examen físico tiene arreflexia aquiliana bilateral, asociada a hiporreflexia rotuliana mayor a derecha, con paresia M4 en las extremidades superiores y M3 en las inferiores. El diagnóstico más probable es:

A) Radiculopatía S1 derecho
B) Polineuropatía desmielinizante aguda
C) Meningitis viral
D) Mielopatía por influenza
E) Miositis viral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Polineuropatía desmielinizante aguda** (opción **B**). Es un síndrome de Guillain Barré clásico. La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 165 · 1.10.2.013 · Síndrome cuadriparético fl

Un paciente de 24 años, sin antecedentes, es traído porque desde que despertó en la mañana no puede movilizar sus cuatro extremidades, sin otros síntomas. Al examen físico se corrobora fuerza totalmente disminuida en todo su cuerpo, sensibilidad normal, reflejos osteotendíneos presentes y simétricos. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Miastenia Gravis
C) Botulismo
D) Lesión medular cervical
E) Parálisis periódica hipokalémica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Parálisis periódica hipokalémica** (opción **E**). Por descarte y así es la parálisis hipokalémica. El Guillain Barré tiene ROT abolidos.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 85 · 1.10.2.013 · Síndrome cuadriparético fl

Un paciente de 38 años consulta por paresia facial bilateral, de una semana de evolución, mayor a izquierda. Además, presenta paresia del sexto bervio craneal izquierdo. Al examen físico tiene disminución generalizada de las fuerzas de las extremidades, con arreflexia e hipotonía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polineuropatía
B) Síndrome de Guillain Barré
C) Miastenia gravis
D) Esclerosis múltiple
E) Infarto de troncoencéfalo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una tetraparesia flácida y arrefléctica, por lo que tiene un síndrome de Guillain Barré. Es clásica la paresia facial bilateral y puede tener afectación de los oculomotores (aunque ello es más probable en una miastenia gravis, cuya clínica, de todos modos, es distinta a la presentada).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 170 · 1.10.2.013 · Síndrome cuadriparético fl

Paciente de 45 años presenta paresia facial bilateral de instalación progresiva, en 2 semanas, a lo que luego se agrega parálisis del sexto par craneal. Al examen físico, el tono muscular está disminuido de forma simétrica en las cuatro extremidades, con reflejos osteotendinosos abolidos. El diagnóstico más probable es:

A) Accidente vascular tronco encefálico
B) Miastenia gravis
C) Sd. de Guillain Barre
D) Botulismo
E) Hemorragia intracraneana

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Sd. de Guillain Barre** (opción **C**). Es un Guillain Barré clásico (tetraparesia fácida y arrefléctica, con parálisis facial bilateral).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 86 · 1.10.2.013 · Síndrome cuadriparético fl

Una mujer de 32 años consulta por debilidad progresiva en ambas piernas, que inició hace 5 días y ha avanzado a las extremidades superiores en las últimas 48 horas. Refiere sensación de hormigueo en manos y pies, pero sin alteración sensorial significativa. No presenta fiebre ni dolor. Hace dos semanas tuvo un cuadro de infección respiratoria con tos y congestión nasal. Al examen físico, destaca debilidad simétrica en las extremidades, arreflexia global y marcha inestable. No hay signos de afectación de los pares craneales.

A) Realizar resonancia magnética de columna
B) Iniciar tratamiento con inmunoglobulina intravenosa
C) Solicitar resonancia magnética de cerebro
D) Administrar corticosteroides endovenosos
E) Iniciar aciclovir endovenoso

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome de Guillain-Barré: La sospecha es un síndrome de Guillain-Barré, que se diagnostica principalmente por la clínica. Se recomienda complementar con punción lumbar (disociación albuminocitológica) o electromiografía. El tratamiento, además del soporte, es inmunoglobulina G intravenosa o plasmaféresis.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 24 · 1.10.2.013 · Síndrome cuadriparético fl

Un paciente de 18 años presenta debilidad progresiva de las extremidades, con dificultad para caminar. Al examen físico no puede ponerse de pie y sus reflejos osteotendíneos están disminuidos, sin afectación de la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:

A) Polirradiculoneuritis desmielinizante
B) Miastenia gravis
C) Polineuropatía
D) Parálisis hipokalémica
E) Mielitis transversa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Polirradiculoneuritis desmielinizante** (opción **A**). Es un Guillain Barré clásico. Otro nombre es Polirradiculoneuritis desmielinizante.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 56 · 1.10.4.006 · Electromiografia

Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 de larga data, mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y que es más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de la sensibilidad de las extremidades con el uso de monofilamento e importante disminución de los pulsos pedios. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Estudio Doppler vascular de extremidades inferiores
B) Electromiografía
C) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
D) Angiografía aortofemoral
E) Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una polineuropatía diabética, cuyo diagnóstico es cínico, por lo que no necesita ningún examen para confirmarse. Sin embargo, la electromiografía es el examen que permite objetivarla.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 56 · 1.10.4.006 · Electromiografia

Un paciente diabético tipo 2, de 58 años, mal controlado, consulta por dolor en las extremidades inferiores, de tipo urente y que es más intenso en la noche. Al examen físico se aprecia ausencia de la sensibilidad de las extremidades con el uso de monofilamento. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Ecodoppler de extremidades inferiores
B) Electromiografía
C) Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra
D) Angiografía aortofemoral
E) Pletismografía de volumen del pulso de extremidades inferiores

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una polineuropatía. La verdad es que el diagnóstico es clínico y no requiere ningún examen, pero de las opciones que aparecen, la B es la única aceptable.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 2 · 1.10.4.006 · Electromiografia

Una mujer de 50 años consulta por parestesias en ambas manos, mayor a derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos, para aliviarse. Además presenta dificultad para tomar objetos con las manos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

A) Ecografía de mano
B) Electromiografía
C) Prueba de estimulación con edrofonio
D) Resonancia magnética de cuello
E) Radiografía de mano

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Electromiografía). El STC se estudia con EMG. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecografía de mano, Prueba de estimulación con edrofonio) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 27 · 1.10.4.006 · Electromiografia

Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 28 semanas, consulta por parestesias en el primer, segundo y tercer dedo de la mano derecha, que empeoran durante la tarde y la noche, asociadas a sensación de debilidad en los mismos dedos. El resto del examen Fsico es normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?

A) Resonancia magné2ca nuclear de cuello
B) Ecogra:a de muñecas
C) Electromiogra:a
D) Radiogra:a de mano derecha
E) Factor reumatoideo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un síndrome de túnel carpiano clásico. La EMG es el examen de elección para evaluar las neuropaVas por atrapamiento.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 23 · 1.10.1.017 · Polineuropatías, radiculop

Un paciente de 69 años presenta debilidad de las manos, asociados a disminución de la sensibilidad de manos y pies. Refiere además dolor tipo ardor en las extremidades inferiores. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad “en calcetín”, signo de Lasegue negativo y presenta abolición de ambos reflejos aquileanos. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Radiculopatía S1
C) Síndrome de cola de caballo
D) Polineuropatía
E) Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Polineuropatía** (opción **D**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 59 1.10.1.017 · Polineuropatías, radiculop

Una paciente de 70 años consulta por dolor tipo urente en las extremidades inferiores, asociado a parestesias, descritas como “hormigueos” en los pies. Al examen físico tiene disminución de la sensibilidad en calcetín, con paresia a la extensión de los ortejos y disminución de ambos reflejos aquilianos. En cambio, los reflejos rotulianos se encuentran conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Radiculopatía S1 bilateral
B) Síndrome de cauda equina
C) Síndrome del cono medular
D) Síndrome de Guillain Barré
E) Polineuropatía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una polineuropatía clásica (ver resumen de semiología neurológica y aprovechar de leerlo entero y aprenderlo).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 119 1.10.1.017 · Polineuropatías, radiculop

Hombre de 55 años con diabetes mellitus de larga data. Presenta debilidad asimétrica en extremidades, afectando nervio peroneo derecho y cubital izquierdo. Sin compromiso de pares craneanos. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Mononeuritis múltiple
B) Polineuropatía diabética simétrica
C) Síndrome de Guillain-Barré
D) ACV múltiple
E) Miopatía inflamatoria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Afectación de nervios periféricos individuales, no contiguos y asimétricos en diabético = mononeuritis múltiple (mononeuropatía múltiple). Causas: diabetes, vasculitis, lepra.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 44 1.10.1.017 · Polineuropatías, radiculop

Un paciente diabético de larga data, mal controlado, en tratamiento con metformina y empaglifozina. Consulta por ptosis y molestias visuales en el ojo derecho. Al examen físico, tiene ptosis del ojo derecho, que se asocia a diplopía al abrir manualmente el párpado. Además, tiene dificultades en la aducción y elevación del ojo derecho. Su agudeza visual se constata como 20/25 bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Accidente vascular encefálico
B) Tumor cerebral
C) Cáncer de pulmón con compromiso del ganglio estrellado
D) Ptosis aponeurótica
E) Parálisis del tercer nervio craneal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parálisis del Tercer Nervio Craneal: Se trata de una parálisis del tercer nervio craneal (oculomotor) clásica. Ptosis + diplopía + dificultad en aducción y elevación ocular en paciente diabético mal controlado.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 45 1.10.1.017 · Polineuropatías, radiculop

Un paciente diabético de larga data, mal controlado, en tratamiento con metformina y empaglifozina. Consulta por ptosis y molestias visuales en el ojo derecho. Al examen físico, tiene ptosis del ojo derecho, que se asocia a diplopía al abrir manualmente el párpado. Además, tiene dificultades en la aducción y elevación del ojo derecho. Su agudeza visual se constata como 20/25 bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Accidente vascular encefálico
B) Tumor cerebral
C) Cáncer de pulmón con compromiso del ganglio estrellado
D) Ptosis aponeurótica
E) Parálisis del tercer nervio craneal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parálisis del Tercer Nervio Craneal: Se trata de una parálisis del tercer nervio craneal (oculomotor) clásica. Se recomienda revisar el resumen de semiología neurológica.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 66 1.10.1.017 · Polineuropatías, radiculop

Paciente de 30 años comienza hace una semana con cuadro de dolor en la espalda y extremidades, a lo que luego se agrega debilidad progresiva que actualmente dificulta la marcha asociado a dificultad para orinar. Al examen físico se constata debilidad de

A) Miastenia gravis
B) Síndrome de Guillain Barre
C) Mielitis transversa
D) Compresión medular toráxica
E) Parálisis hipokalémica episódica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
B? La clínica es sugerente de un Sd. Guillain Barré, pero el dolor de espalda, la afec- tación vesical y en especial el nivel sensitivo obliga a descartar una mielitis transversa; sin embargo, el nivel era torácico y la afectación motora era de las 4 extremidades y el Guillain Barré sí puede tener esos síntomas. Es una mala pregunta, ya que el cuadro clí- nico no era lo suficientemente limpio, como para elegir una de las dos opciones.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 94 1.10.1.013 · Neuralgia esencial del tri

Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que compromete la arcada dentaria superior y la encía, así como la zona maxilar superior del lado izquierdo. Además presenta dolor retro ocular izquierdo. El dolor es de escasos segundos, pero intenso EVA 10/10, que se al tacto y al realizar actividades, como cepillarse los dientes e incluso una suave brisa puede desencadenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para este cuadro?

A) Pregabalina
B) Tramadol
C) Prednisona
D) Paracetamol y AINEs
E) Amoxicilina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una neuralgia del trigémino y de primera línea se dan carbamazepina u otros anticonvulsivantes, aunque también sirven los antidepresivos tricíclicos. De segunda línea, se puede agregar la pregabalina (lo habitual es CBZ y luego pregabalina).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 28 1.10.1.013 · Neuralgia esencial del tri

Una paciente de 55 años consulta por dolor facial de 3 meses de evolución, de carácter lancinante, que afecta la mejilla y el ala nasal derechas, además del labio superior y la arcada dental del lado derecho. El dolor es muy intenso y se desencadena ante acciones como tocarse la cara, lavarse los dientes y comer, en incluso por una brisa suave. El dolor dura solo unos pocos segundos, sin embargo, su intensidad es muy alta, con EVA 10/10. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A) Pregabalina
B) Amitrip2lina
C) Venlafaxina
D) Carbamazepina
E) Tramadol

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una neuralgia del trigémino clásica. De elección se usa la carbamazepina. De segunda línea, se pueden usar algunos de los otros fármacos. Vale la pena recordar que en la neuralgia postherpé<ca, en cambio, de primera línea es la pregabalina.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 25 1.10.1.013 · Neuralgia esencial del tri

Un paciente de 37 años consulta por dolor en la mandíbula inferior de segundos de duración, muy intenso, EVA 9/10, que se gatilla al comer y al lavarse los dientes. El dolor se ubica en la mitad izquierda de la mandíbula y en la arcada dental inferior izquierda. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnístico más probable?

A) Neuralgia del trigémino
B) Cefalea cluster
C) Jaqueca clásica
D) Jaqueca complicada
E) Disfunción de la articulación temporomandibular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Neuralgia del trigémino). Neuralgia de la rama mandibular (V3) del trigémino.. Esta clase cubre los síndromes sensitivos: polineuropatías, neuralgias y neuropatías por atrapamiento, más algunos cuadros raros como la parálisis del borracho y la parálisis de la luna de miel. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 22 1.10.1.006 · Enfermedad de Parkinson y

Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha asociado a dificultades para iniciar la marcha. Relata que se había caído hacia adelante, en dos oportunidades, al empezar a caminar. Al inicio de la marcha es lento e inseguro, pero luego alcanza una velocidad normal, la que se mantiene por el resto del tiempo. No presenta disminución de las fuerzas de las extremidades y sus reflejos osteotendíneos son normales, al igual que la sensibilidad. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Parkinson
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Polineuropatía diabética
D) Polimialgia reumática
E) Miopatía por cuerpos de inclusión

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una anfermedad de Parkinson clásico: temblor de reposo, bradicinesia y problemas de inicio de marcha.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 26 1.10.1.006 · Enfermedad de Parkinson y

Un paciente de 70 años presenta un cuadro de dificultad para girarse y para meterse a la tina, asociado a múltiples caídas. Además presenta cambios en la escritura y temblor de reposo. No presenta deterioro cognitivo evidente. El diagnóstico más probable es:

A) Atrofia generalizada
B) Hidrocefalia normotensiva
C) Temblor senil
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Enfermedad de Parkinson

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Parkinson** (opción **E**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 40 1.10.1.006 · Enfermedad de Parkinson y

Paciente en tratamiento anti hipertensivo + sd vertiginoso en tto con Cinarizina, metformina, inicia temblor de reposo, simétrico, bilateral, rigidez y asociado a caídas frecuentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parkinson POR QUÉ NO PODÍA SER PÁRKINSON ? Porque describía un temblor bilateral simétrico, Parkinson inicia como unilateral y no simétrico
B) Parkinsonismo por fármacos
C) Accidente cerebrovascular
D) Epilepsia
E) Esclerosis múltiple

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Parkinson POR QUÉ NO PODÍA SER PÁRKINSON ? Porque describía un temblor bilateral simétrico, Parkinson inicia como unilateral y no simétrico** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 99 1.10.1.006 · Enfermedad de Parkinson y

Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con doxazosina, hiperplasia prostá8ca benigna en tratamiento con tamsulosina y trastorno afec8vo bipolar en tratamiento con carbonato de li8o, consulta por temblor de manos mayor a derecha que aparece con el reposo y se asocia a len8tud en los movimientos. El cuadro inició hace 4 meses. Se miden los niveles plasmá8cos de los fármacos que u8liza, los que son informados dentro de rango terapéu8co. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender la doxazosina
B) Disminuir la dosis de carbonato de li2o
C) Suspender la tamsulosina
D) Realizar prueba con levodopa
E) Iniciar propranolol vía oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La bradicinesia (lentitud de movimientos) más temblor obliga a pensar en enfermedad de Parkinson, cuyo diagnóstico es clínico, pudiendo hacer una prueba con levodopa para ver si mejoran los síntomas. La intoxicación por liGo sí puede producir temblor, pero suele ser aguda y, además, explícitamente se reportan niveles dentro de rango terapéutico.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 171 1.10.1.006 · Enfermedad de Parkinson y

(178) Paciente de 78 años con antecedentes de HTA DM2 vértigo recurrente en tratamiento con Losartán Metformina y Cinarizina. Consulta por 3 meses de temblor en EESS y caídas frecuentes. Al examen físico temblor de reposo en EESS bilateral y simétrico, leve rigidez y marcha enlentecida. Sin focalidad, sin alteraciones en la sensibilidad, Minimental 30/30

A) Temblor esencial
B) Neuropatía DM
C) Hidrocefalia normotensiva d. Parkinsonismo por fármacos (cinarizina)
E) Enfermedad de Parkinson
E) Accidente cerebrovascular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Hidrocefalia normotensiva d. Parkinsonismo por fármacos (cinarizina)** (opción **C**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 129 1.10.1.005 · Demencia (Enfermedad de Al

Paciente con 1 año de alucinaciones visuales, pérdida de memoria progresiva, rigidez, hipocinesia y alteración de la marcha. ¿Diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Parkinson con demencia
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Demencia frontotemporal
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Parálisis supranuclear progresiva

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Demencia por cuerpos de Lewy** (opción **D**). Demencia por cuerpos de Lewy. Esta clase aborda el compromiso de conciencia, las apraxias, agnosias y los trastornos del lenguaje. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 35 1.10.1.005 · Demencia (Enfermedad de Al

Un paciente de 82 años, hace 2 años sufrió un accedente vascular encefálico, sin secuelas. Hace 2 meses presenta un cuadro de labilidad emocional, desinhibición social y dificultades para realizar algunas de sus actividades habituales. El diagnóstico más probable es:

A) Depresión
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Demencia vascular
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Hidrocéfalo normotensivo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una clásica demencia vascular de tipo subcortical. Es una pregunta muy difícil, pero el antecedente de AVE es algo muy sugerente y la labilidad emocional y desinhibición son sugerentes de la localización subcortical. Si no hubiese estado en las opciones, sería una depresión.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 85 1.10.1.005 · Demencia (Enfermedad de Al

Un paciente de 55 años ha presentado varios cambios congnitivos conductuales, como tendencia a la apatía, lenguaje coprolálico o andar desnudo. No ha tenido alteraciones en la conciencia ni en la memoria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Demencia por cuerpos de Lewy
B) Hidrocefalia normotensiva
C) Enfermedad de Alzheimer
D) Demencia frontotemporal
E) Delirium

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Demencia frontotemporal** (opción **D**). Cuadro clásico. Esta clase aborda el compromiso de conciencia, las apraxias, agnosias y los trastornos del lenguaje. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 85 1.10.1.026 · Temblor esencial

Un paciente de 72 años consulta por temblor ambas extremidades, que aparece al realizar sus actividades habituales. Al examen físico se observa el mencionado temblor, sin otras alteraciones en la exploración neurológica. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de sus síntomas?

A) Diazepam
B) Alprazolam
C) Propranolol
D) Levodopa
E) Sertralina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Temblor Esencial: El cuadro clínico describe un temblor esencial, caracterizado por una exploración neurológica normal, salvo por temblor que aumenta con la postura o actividad. El tratamiento de elección es propranolol oral.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 161 1.10.1.026 · Temblor esencial

Paciente masculino, de 71 años de edad, con un cuadro de 2 años de evolución de temblor de ambas extremidades superiores, lo cual le sucede al escribir, tomar un objeto, o al usar cubiertos. Toma alprazolam 0,5 mg/dl, dos veces por día por cuadro ansioso. Al examen físico no tiene temblor de reposo y se observan reflejos osteotendíneos conservados, con tono muscular y sensibilidad normal. El temblor se acentúa al tratar de tomar un objeto. El diagnóstico más probable es:

A) Hipertiroidismo
B) Enfermedad de Parkinson
C) Temblor esencial
D) Temblor por ansiedad
E) Temblor por medicamentos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es el cuadro típico del temblor esencial: temblor bilateral que aumenta al adoptar una postura y disminuye con el alcohol y las BDZ (benzodiacepinas).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 147 1.10.1.026 · Temblor esencial

Adulto mayor con temblor al escribir, un temblor esencial ¿Con que se trata? a. Propanolol

A) Accidente cerebrovascular
B) Epilepsia
C) Esclerosis múltiple
D) Enfermedad de Parkinson
E) Migraña

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Accidente cerebrovascular). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Epilepsia, Esclerosis múltiple) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 57 1.10.1.015 · Parálisis (tetraparesia, h

Un hombre de 58 años presenta un cuadro de 3 años de evolución de debilidad progresiva de las extremidades, que trae problemas para caminar, hasta no poder hacerlo, a lo que luego se agrega dificultad para tragar. Evoluciona finalmente con dificultad respiratoria y necesidad de traqueostomía. No tiene alteración sensitiva. Se solicita espirometría que se muestra a continuación ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Polineuropatía diabética
B) Distrofia muscular
C) Esclerosis múltiple
E) Esclerosis lateral amiotrófica
E) Hemograma y VHS

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Esclerosis lateral amiotrófica** (opción **E**). Es una ELA clásica. La espirometría mostraba un patrón restrictivo.. Esta clase aborda los síndromes motores: diferenciación entre primera y segunda motoneurona, miopatías vs neuropatías, miastenias, síndrome de Guillain-Barré y mielitis transversa. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 15 1.10.1.015 · Parálisis (tetraparesia, h

Un paciente presenta disfonía y disartria, como secuela, luego de haber sufrido un traumatismo enceflaocraneano. Evoluciona posteriormente con múltiples neumonías aspirativas. ¿Cuál es la causa más probable de estas neumonías?

A) Reflujo gastroesofágico
B) Estenosis subglótica
C) Divertículo esofágico
D) Trastorno de la deglución
E) Parálisis frénica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Trastorno de la deglución). Es un trastorno de la deglución clásico, en este caso como secuela de un TEC severo.. Esta clase aborda los síndromes motores: diferenciación entre primera y segunda motoneurona, miopatías vs neuropatías, miastenias, síndrome de Guillain-Barré y mielitis transversa. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 59 1.10.1.001 · Cefalea tensional

Un paciente de 40 años consulta por cefalea holocránea, mayor en la zona occipital, que se irradia al cuello. Suele iniciarse a medio día y alcanza su máxima intensidad al llegar a su casa, después del trabajo. Su examen neurológico no tiene signos focales ni meníngeos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cefalea tensional
B) Migraña
C) Cefalea en racimo o cluster
D) Cefalea por hipertensión endocraneana
E) Neuralgia de Arnold

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cefalea tensional** (opción **A**). Es una cefalea tensional clásica (como la que da al salir del Eunacom).. El tratamiento de la artritis reumatoide se basa en las drogas modificadoras de la artritis reumatoide (DMARs). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 97 1.10.2.021 · Traumatismo encefalocranea

Un adolescente de 17 años sufre un accidente de tránsito, en bicicleta, con golpe en la cabeza. Inicialmente está sin signos neurológicos focales, con escala de Glasgow de 15. Se solicita una radiografía de cráneo que muestra una fractura de la escama del temporal. A las 2 horas evoluciona con cefalea intensa y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Se aprecia midriasis derecha, arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hematoma subdural derecho
B) Hematoma epidural derecho
C) Hemorragia subaracnoidea
D) Contusión encefálica frontal
E) Contusión encefálica temporal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un hematoma epidural clásico, tanto por la fractura, como por la clínica de HTEC grave, como por el breve intervalo lúcido.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 142 1.10.2.021 · Traumatismo encefalocranea

Un paciente de 72 años sufre una caída en bicicleta, golpeando la cabeza contra el suelo. Es llevado a un servicio de urgencia donde se encuentra en buenas condiciones, sin alteraciones del nivel de conciencia ni del examen neurológico, por lo que es dado de alta a su domicilio, con indicación de reposo y control SOS. Tres días después inicia cefalea progresiva y, al día siguiente, se agregan vómitos y dificultad para mover las extremidades derechas. Al examen Fsico se encuentra vigil, orientado en el espacio, pero desorientado en el 8empo. En el examen neurológico destaca hemiparesia derecha. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hematoma epidural
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Hematoma intraparenquimatoso
D) Trombosis del seno cavernoso
E) Hematoma subdural

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Todo adulto mayor con un TEC debe ser estudiado con TAC de cerebro y cráneo, precisamente porque Genen mayor riesgo de presentar un hematoma subdural. Además, es frecuente que se demore en desarrollar síntomas y alteraciones neurológicas, porque se origina en un sangrado venoso, que puede ser bastante lento. La edad avanzada y la atrofia cerebral son los factores de riesgo más importantes, ya que permiten una mayor movilidad de las venas que se lesionan.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 41 1.10.1.007 · Epilepsia

Un niño de 16 años convulsiona al despertar, en la mañana siguiente de haber estado jugando videojuegos hasta tarde. Además, refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Suspender por completo los videojuegos
B) Ácido valproico
C) Carbamazepina
D) Melatonina en la noche
E) Diazepam si convulsiona nuevamente

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una epilepsia mioclónica. Los niños con epilepsia sí pueden ver pantallas, pero máximo 1 hora al día, con una buena iluminación.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 133 1.10.1.007 · Epilepsia

Una paciente de 14 años sufre una convulsión tónico clónica, luego de una noche con privación de sueño y exposición a pantallas. Previo a esto, presentaba movimientos bruscos, como sacudidos, de manera involuntaria. Sus amigas relatan que en ocasiones “se queda pegada” por algunos segundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Epilepsia mioclónica juvenil
B) Epilepsia de ausencia juvenil
C) Epilepsia tónicoclónica
D) Epilepsia focal
E) Crisis convulsiva por privación de sueño

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Epilepsia mioclónica juvenil** (opción **A**). Es una epilepsia mioclónica clásica.. Esta clase aborda las crisis convulsivas, la epilepsia, las convulsiones febriles y el estatus convulsivo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 140 1.10.1.007 · Epilepsia

Niño o adolescente con conducta disruptiva + crisis de ausencia ¿Como estudiarlo?

A) Electroencefalograma
B) TAC
C) RNM
D) Psicometria
E) Control sano habitual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Electroencefalograma** (opción **A**). Crisis focal (por lesión focal): RM/TAC con contraste + carbamazepina/fenitoína. Crisis generalizada (epilepsia/tóxico-metabólica): exámenes generales + EEG + ácido valproico/lamotrigina. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 143 1.10.1.007 · Epilepsia

Paciente con mirada forzada hacia la derecha, luego espasmo hemifacial, luego movimientos de sacudidas en las 4 extremidades. ¿Diagnóstico más probable?

A) Crisis focal con generalización secundaria
B) Crisis tónico-clónica generalizada primaria
C) Estatus epiléptico no convulsivo
D) Accidente isquémico transitorio (AIT)
E) Crisis mioclónica juvenil

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Crisis focal con generalización secundaria** (opción **A**). Crisis focal con generalización secundaria. Esta clase aborda las crisis convulsivas, la epilepsia, las convulsiones febriles y el estatus convulsivo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 142 1.10.1.029 · Tumores primarios y metast

Un niño de 6 años presenta múltiples en el tronco, que se muestran en la imagen. Su padre tiene lesiones similares. INSERTAR FOTO El diagnóstico más probable es:

A) Neurofibromatosis tipo 1
B) Enfermedad de Addison
C) Enfermedad celiaca
D) Síndrome de Peutz-Jeghers
E) Hiperplasia suprarrenal congénita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Neurofibromatosis tipo 1** (opción **A**). Eran manchas café con leche, que si son más de 6, se asocian a NF1.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 126 1.10.2.014 · Síndrome encefalítico (Her

Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea de 3 días de evolución, a lo que se le ha agregado desorientación y confusión. Además, ha presentado algunas convulsiones clónicas. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 células por mm3, con 90% mononucleares, con 15 glóbulos rojos por mm3, glucosa: 80 mg/dl, proteínas: 40 mg/dl; glicemia: 100 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Toxoplasmosis cerebral
B) Meningoencefalitis herpética
C) Tumor cerebral
D) Meningitis viral
E) Meningitis bacteriana aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una encefalitis herpética clásica: anteraciones conductuales, convulsiones, compromiso de conciencia, líquido cefalorraquídeo compatible con meningitis viral, pero hemorrágico. Lo unico raro era la edad, ya que suele afectar a personas más jóvenes.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 42 1.10.2.014 · Síndrome encefalítico (Her

Paciente con cefalea importante que convulsiona y tiene compromiso de conciencia? (soporoso?), con LCR MN y GR:

A) Encefalitis por VHS
B) MAB
C) Meningitis viral
D) Accidente cerebrovascular
E) Epilepsia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Encefalitis por VHS). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (MAB, Meningitis viral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 144 1.10.2.015 · Síndromes convulsivos sint

Un adolescente de 14 años presenta cefalea de una semana de evolución. Es traído al servicio de urgencia, tras presentar una convulsión tónico-clónica de 10 minutos de duración, luego de lo que quedó con confusión postictal. Su examen físico no tiene signos focales. Se solicita una tomografía axial computada de cerebro, que muestra una lesión quística de 3 cm en la zona frontotemporal y se realiza una punción lumbar, que muestra proteínas 60 mg/dl, con 70 células por mm3, con 70% de mononucleares y presencia de abundantes eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste aracnoidal
B) Astrocitoma pilocítico
C) Encefalitis herpética
D) Meningitis tuberculosa
E) Neurocisticercosis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien es una pregunta rara, que tenga una lesión quística, más eosinófilos en el LCR hace que sea una neurocisticercosis por Taenia solium.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 104 1.10.1.008 · Esclerosis múltiple

Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega disminución de la sensibilidad del muslo derecho, con dificultades para caminar. Como antecedente, refiere que hace un año tuvo un trastorno del equilibrio, que resolvió espontáneamente. El diagnóstico más probable es:

A) Polineuropatía por déficit de vitamina B12
B) Síndrome de Guillain Barré de presentación atípica
C) Infarto talámico
D) Esclerosis múltiple
E) Neurinoma con compresión del troncoencéfalo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, pero el cuadro solo es compatible con una esclerosis múltiple ya que ha tenido múltiples signos focales, de inicio subagudo, que pueden recuperarse (como el trastorno del equilibrio). Revisar el resumen de semiología neurológica.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 17 1.10.1.008 · Esclerosis múltiple

Una paciente de 14 años presenta disminución de la visión del izquierdo, de dos días de evolución. Su agudeza visual es 20/200 en el ojo izquierdo y 20/20 en el derecho. Tiene antecedente de hemiparesia braquial. Al fondo de ojo se observa papilitis izquierda. Su resonancia magnética nuclear muestra lesiones desmielinizantes cerebrales. El diagnóstico más probable es:

A) Desprendimiento de retina
B) Neuritis óptica
C) Neuropatía óptica isquémica
D) Degeneración macular
E) Hipertensión endocraneana

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una neuritis óptica clásica, en contexto de una esclerosis múltiple. El edema de papila bilateral es clásico de la HTEC, pero la NO también tiene edema de papila, ya que ahí es donde nace el nervio óptico.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 98 1.10.1.027 · Trastornos del sueño

Hombre de 65 años con antecedente de enfermedad de Parkinson. Su pareja refiere que durante el sueño emite gritos, golpea y patea. El paciente no recuerda nada al despertar. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trastorno de conducta del sueño REM (RBD)
B) Sonambulismo
C) Terrores nocturnos
D) Apnea obstructiva del sueño
E) Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Comportamientos violentos durante el sueño REM en paciente con Parkinson = trastorno de conducta del sueño REM (RBD). Es el parasomnia más frecuente en sinucleinopatías. El sujeto actúa sus sueños.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 122 1.10.1.027 · Trastornos del sueño

Paciente que durante el sueño se levanta, grita y golpea, al despertar refiere que soñaba que se defendía. ¿Diagnóstico más probable?

A) Sonambulismo
B) Terror nocturno (pavor nocturnus)
C) Trastorno conductual del sueño REM
D) Pesadillas recurrentes
E) Epilepsia nocturna del lóbulo frontal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno conductual del sueño REM** (opción **C**). Trastorno conductual del sueño REM. Esta clase cubre los principales trastornos del sueño: insomnio, hipersomnia, síndrome de piernas inquietas, pesadillas y terrores nocturnos, y narcolepsia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 84 1.10.1.027 · Trastornos del sueño

Un paciente de 75 años ha presentado varios episodios durante el sueño, en los que tiene movimientos bruscos, actuando sus sueños, llegando incluso a golpear a su a su esposa en una oportunidad, mientras dormía. Cuando despertó comentó que estaba soñando que lo atacaban, por lo que se estaba defendiendo. Se muestra muy preocupado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sonambulismo
B) Epilepsia de lóbulo frontal
C) Enfermedad de Parkinson
D) Trastorno conductual del sueño REM
E) Síndrome confusional agudo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome confusional agudo** (opción **E**). Esta clase cubre los principales trastornos del sueño: insomnio, hipersomnia, síndrome de piernas inquietas, pesadillas y terrores nocturnos, y narcolepsia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 99 1.10.2.006 · Encefalopatías tóxico meta

Una paciente de 20 años es encontrada inconsciente en el baño por sus familiares, con el piloto del calefont apagado, por lo que es llevada al servicio de urgencia de inmediato, recuperándose parcialmente en el camino. Al examen físico está consciente, responde al interrogatorio y coopera, aunque está soporosa y se queja de muchas náuseas y cefalea intensa. Satura 97% a FiO2 ambiental, tiene frecuencia cardíaca de 90x' y presión arterial 146/92 mmHg. Su examen cardiopulmonar resulta normal. Cuál es el examen de elección para

A) Radiografía de tórax
B) Resonancia magnética nuclear de cerebro
C) Carboxihemoglobina
D) Gases en sangre arterial
E) TAC de cerebro sin contraste

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (TAC de cerebro sin contraste). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Radiografía de tórax, Resonancia magnética nuclear de cerebro) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 166 1.10.2.003 · Crisis convulsiva

Una mujer de 17 años, presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha, cayendo al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que mantuvo mirada conjugada hacia derecha, tras lo cual presentó hipertonía de todo el cuerpo, seguido de movimientos rítmicos de las 4 extremidades. Se recupera somnolienta y adolorida, con signos de haberse mordido la lengua, con impresión de la arcada dentaria en zona lateral de la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Crisis convulsiva primariamente generalizada
B) Crisis focal secundariamente generalizado
C) Síncope vasovagal
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno facticio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Crisis focal secundariamente generalizado** (opción **B**). Esta clase aborda el manejo del traumatismo encéfalo craneano (TEC), diferenciando entre TEC simple y severo según la presencia de signos de alarma. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 5 1.10.1.009 · Herpes zoster

Una mujer de 64 años consulta por dolor intercostal intenso de 3 semanas de evolución, que fue antecedido por la aparición de lesiones vesiculares en esa zona. En el examen físico se observa curación de las lesiones, algunas de las que dejaron cicatrices, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el manejo del dolor?

A) Pregabalina
B) Galantamina
C) Amitriptilina
D) Carbamazepina
E) Fluoxetina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Neuritis posherpética: La sospecha clínica es de neuritis posherpética. El tratamiento de primera línea es la pregabalina o la gabapentina, siendo la pregabalina la más utilizada. La carbamazepina o los antidepresivos tricíclicos, que antes eran el tratamiento de primera línea, ahora se consideran de segunda línea.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 74 1.10.1.020 · Síndrome miasténico

Una paciente de 38 años, profesora de enseñanza básica, consulta por debilidad y mialgias generalizadas, que iniciaron hace un mes. Además, refiere ptosis a derecha, que suele ser mayor en las tardes. Al examen físico se constata ptosis bilateral, mayor a derecha, con normalidad de los reflejos osteotendíneos y la sensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esclerosis lateal amiotrófica
B) Polimiositis
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Esclerosis múltiple
E) Miastenia gravis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Miastenia Gravis: El caso presentado corresponde a una miastenia gravis clásica. Se recomienda repasar el resumen de semiología neurológica.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 80 1.10.1.028 · Tumores de región sellar

Una mujer de 55 años consulta por cefalea progresiva, de localización interciliar y occipital, asociada a alteraciones visuales. Al examen físico, tiene hemianopsia heterónima, sin alteraciones motoras ni de la sensibilidad. ¿En qué estructura anatómica se encuentra con mayor probabilidad la lesión?

A) En las retinas
B) En ambos nervios ópticos
C) En el lóbulo occipital
D) En la radiación óptica
E) En el quiasma óptimo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tumor Hipofisario con Compromiso del Quiasma Óptico: La sospecha es un tumor hipofisario que afecta el quiasma óptico, causando hemianopsia heterónima bitemporal. La alteración del nervio óptico produce amaurosis, mientras que las lesiones del lóbulo occipital, radiaciones y cintilla óptica se manifiestan como hemianopsia homónima contralateral.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 151 1.10.3.002 · Prevención de factores de

Una paciente de 67 años presenta un cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural derecha autolimitada hace 7 días, manejada adecuadamente en el hospital. Al examen físico se ausculta un soplo cervical izquierdo, sin otras alteraciones. Su examen neurológico es normal. ¿Cuál de los siguientes es el examen más adecuado para realizar el estudio etiológico?

A) Ecocardiograma Doppler color
B) Angiografía de arterias cerebrales o de cabeza y cuello
C) Resonancia magnética de cerebro
D) Ecodoppler de carótidas
E) TAC de cerebro

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Estudio de Fuente Embólica Accidente Isquémico Transitorio: Tras un accidente isquémico transitorio (AIT), se debe buscar la fuente embólica con ecodoppler de carótidas, ecocardiograma y Holter de arritmias. En este caso, la presencia de un soplo en el cuello hace que el ecodoppler de carótidas sea lo más importante. Se maneja con endarterectomía carotídea si la estenosis es mayor al 70%, o mayor al 50% con síntomas como AIT o accidente cerebrovascular.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 29 1.10.1.024 · Síndromes vertiginosos cen

Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, consulta por vér8go intenso de inicio súbito hace 2 horas, asociado a dificultades en la marcha que le impiden mantenerse de pie. Al examen Fsico se observa hipotónico, con dismetría de extremidades y nistagmus mul8direccional. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar difenidol
B) Realizar examen de VIII par
C) Solicitar prueba calórica
D) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de troncoencéfalo
E) Solicitar TAC de cerebro

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un vérGgo de Gpo central, por el nistagmo mulGdireccional y la dismetría (propio de los síndromes cerebelosos). Con ello, se debe solicitar una neuroimagen. Si bien la RMN ve mejor la fosa posterior y, probablemente, se solicite después, lo más urgente es la TAC de cerebro, ya que es un examen rápido y la primera sospecha es un ACV cerebeloso o del sistema vertebrobasilar, que está dentro de la ventana de trombólisis, en caso de que sea isquémico.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 89 1.10.1.018 · Síndrome atáxico

Un paciente de 75 años, con antecedente de EPOC en tratamiento con broncodilatadores inhalados y bromhexina 8mg cada 8h, más consumo de alcohol de una botella de vino de 750 cc durante los fines de semana, consulta por dificultades para caminar y hablar de 3 meses de evolución, progresivas, asociadas a torpeza de las extremidades. No ha presentado náuseas ni cefalea. Al examen Fsico, se aprecia ataxia de la marcha, habla disártrica y dismetría de las extremidades superiores, con imposibilidad de realizar movimientos alternantes de forma coordinada. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Toxicidad cerebelosa por bromhexina
B) Degeneración cerebelosa alcohólica
C) Esclerosis múl2ple
D) Síndrome paraneoplásico
E) Tumor cerebeloso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy difícil, aunque Gene un claro síndrome cerebeloso. Sin embargo, no queda clara la causa. Tiene factores de riesgo para cáncer pulmonar, que puede producir una cerebeliGs autoinmune, siendo compaGble el cuadro con la velocidad que se instauró. No Gene náuseas ni cefalea para pensar en un tumor. El consumo de alcohol no es muy grande y el daño cerebeloso por alcohol suele ser de instalación mucho más lenta. La bromhexina no suele producir toxcicidad cerebelosa y, en caso de hacerlo, es muy raro. El ACV cerebeloso (no está en las opciones) suele instalarse de forma súbita. La esclerosis múlGple también se instala más rápido en algunos pocos días. En resumen, la velocidad con la que progresa hace pensar en una cerebeliGs autoinmune paraneoplásica.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 169 1.10.1.019 · Síndrome de hipertensión e

Una paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con an8inflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea más intensa de lo habitual, desde hace dos meses, que inicialmente era mayor durante la mañana, pero que ha aumentado en intensidad durante todo el día y se ha asociado a náuseas y vómitos explosivos. Refiere no haber tenido respuesta a pesar del uso frecuente de analgésicos y ergotamínicos. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de hipertensión endocraneana
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Encefalopaaa hipertensiva
D) Tumor cerebral
E) Cefalea por ergotamínicos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El predominio maGnal y la presencia de náuseas y vómitos orienta a hipertensión endocraneana (HTEC). De hecho, el síndrome de HTEC completo es cefalea de predominio maGnal, náuseas / vómitos y edema de papila en el fondo de ojo. Por ello, se debe realizar un fondo de ojo y solicitar una neuroimagen.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 104 1.10.1.003 · Cuadros de deterioro orgán

Hombre de 72 años con cefalea holocraneal progresiva de 3 meses de evolución, asociada a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. TAC de cerebro: colección hipodensa crónicamente organizada entre el córtex y el hueso craneal, sin efecto de masa severo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tumor cerebral primario
B) Metástasis cerebrales
C) Hematoma subdural crónico
D) Hidrocefalia normotensiva
E) Enfermedad de Alzheimer

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hematoma subdural crónico en adulto mayor: cefalea crónica + ataxia + deterioro cognitivo + colección hipodensa (crónica >3 semanas) entre córtex y cráneo en TAC = hematoma subdural crónico. Frecuentemente sin traumatismo recordado. Tratamiento: trépano de drenaje si sintomático.

CIRUGÍA GENERAL & ANESTESIA

Módulo 2: Cirugía y Especialidades · Colección Tomo 11

97 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

49 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.008	Cáncer gástrico	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.012	Megacolon	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.016	Hemorroides - fisura anal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.017	Abscesos y fístulas ano rectales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.7 (Pág. 30)
4.01.1.018	Enfermedades del seno pilonidal	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.019	Cáncer anal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.020	Fisura anorectal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.021	Hernias, eventraciones y evisceraciones	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.6 (Pág. 26)
4.01.1.026	Ictericia obstructiva	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 11 · C.13 (Pág. 30)
4.01.1.027	Litiasis biliar	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.028	Cáncer de vesícula y vías biliares	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.032	Masa cervical y tumores del cuello	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.035	Cáncer de mama	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.036	Patología mamaria benigna	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.043	Síndrome de ocupación pleural	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.047	Insuficiencia arterial crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.048	Várices. Insuficiencia venosa crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.049	Trombosis venosa profunda y tromboflebitis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.050	Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.051	Pie diabético	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.1.053	Tumores benignos de partes blandas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.8 (Pág. 32)
4.01.1.054	Tumores malignos de partes blandas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.055	Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.056	Secuelas de quemaduras	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.1.060	Obesidad mórbida	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.003	Peritonitis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 11 · 11.5 (Pág. 21)
4.01.2.005	Obstrucción Intestinal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	12 Q	Tomo 11 · 11.4 (Pág. 17)
4.01.2.006	Apendicitis aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 11 · 11.1 (Pág. 5)
4.01.2.007	Isquemia mesentérica aguda	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.008	Enfermedad diverticular complicada	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.3 (Pág. 13)
4.01.2.010	Trauma abdominal abierto y cerrado	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.11 (Pág. 45)
4.01.2.011	Colecistitis aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.2 (Pág. 9)
4.01.2.014	Heridas de cara	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.016	Traumatismo torácico grave	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 11 · 11.10 (Pág. 41)
4.01.2.019	Perforación esofágica - Mediastinitis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.022	Aneurisma de aorta abdominal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.024	Hemorragia aguda post operatoria.	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.2.026	Quemaduras	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.13 (Pág. 53)
4.01.2.028	Intoxicación por anestésicos locales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · 11.15 (Pág. 62)
4.01.3.002	Antimicrobianos. Conceptos profilaxis y esquemas terapéuticos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.3.005	Complicaciones postoperatorias frecuentes	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 11 · 11.16 (Pág. 66)
4.01.3.012	Diagnóstico precoz del cáncer mamario	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.4.002	Radiografía simple de abdomen	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.4.008	Radiografías contrastadas (EED, tràsnito intestinal,	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.4.009	Mamografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.5.016	Fibrobroncoscopía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.5.017	Hemostasia con ligaduras y taponamiento de heridas sangrantes	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)
4.01.5.018	Intubación traqueal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.01.5.021	**Manejo de drenajes**	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 11 · Cirugía General (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 32 4.01.2.016 · Traumatismo torácico grave

Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Pedir radiografía de tórax
B) Pedir resonancia magnética de tórax
C) Instalar un tubo pleural
D) Solicitar TAC de tórax
E) Realizar videotoracoscopía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una probable herida penetrante de tórax, con un neumotórax traumático. No tiene clínica de neumotórax a tensión, así que no hay que puncionar el segundo espacio intercostal. Lo primero siempre es pedir la radiografía de tórax, tanto para ver el grado del neumotórax, como para descartar otras complicaciones (ej: hemotórax).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 123 4.01.2.016 · Traumatismo torácico grave

Un paciente de 32 años sufre accidente de tránsito, golpeándose el pecho contra el piso. Algunos minutos después evoluciona con dificultad respiratoria, malestar general y compromiso del nivel de conciencia, siendo llevado al servicio de urgencias. Se constata frecuencia cardíaca: 140 por minuto, presión arterial: 86/50 mmHg, frecuencia respiratoria; 45 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno: 82% a aire ambiental. En el examen segmentario, se observa ingurgitación yugular con desviación de la tráquea y se ausculta disminución del murmullo pulmonar derecho y ruidos cardíacos apagados. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Contusión pulmonar
B) Taponamiento cardíaco
C) Disección aór2ca
D) Neumotórax hipertensivo
E) Hemotórax masivo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un neumotórax a tensión clásico. El taponamiento cardíaco también Gene taquicardia, hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados, pero no presenta desviación de la tráquea ni disminución de murmullo pulmonar. Se debe descomprimir de inmediato, mediante toracostomía de urgencia o punción pleural.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 71 4.01.2.016 · Traumatismo torácico grave

Paciente de 25 años tras accidente de tránsito llega con timpanismo a la percusión del hemitórax derecho, ausencia de murmullo vesicular derecho, disnea severa y desviación traqueal hacia la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta inmediata?

A) Neumotórax a tensión: descompresión con aguja en 2° espacio intercostal
B) Hemotórax masivo: drenaje pleural
C) Contusión pulmonar: oxígeno y observación
D) Fractura de costillas: analgesia
E) Taponamiento cardíaco: pericardiocentesis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Timpanismo + ausencia MV + desviación traqueal contralateral = neumotórax a tensión. Emergencia: descompresión inmediata con aguja (2° EIC línea medioclavicular) sin esperar Rx.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 102 4.01.2.016 · Traumatismo torácico grave

Una paciente de 56 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico de alta energía. Presenta múltiples lesiones, hemorragia masiva, taquicardia, hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Se sospecha una fractura de pelvis en el examen físico. Se solicitan imágenes, entre las que se informan una TAC cerebral con un hematoma subdural izquierdo con desplazamiento de 11 mm desde la línea media de la masa encefálica; una TAC de tórax revela múltiples fracturas costales, neumotórax izquierdo con desplazamiento de la tráquea hacia la derecha; TAC de abdomen y pelvis con fractura de pelvis desplazada. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es la más urgente?

A) Intubación orotraqueal
B) Laparotomía exploradora
C) Evacuación quirúrgica del hematoma subdural
D) Pleurostomía izquierda
E) Estabilización de la fractura de pelvis con un dispositivo de compresión neumática

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Neumotórax a Tensión: El paciente presenta múltiples lesiones, pero la más urgente de atender es un neumotórax a tensión (desplazamiento de la tráquea e hipotensión arterial). En este contexto, la pleurostomía se presenta como el procedimiento más urgente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 33 4.01.2.016 · Traumatismo torácico grave

Hombre politrauma se hace TAC hematoma epidural + neumotórax con desviación de tráquea + derrame pericardico extenso, que vuelve del TAC con deterioro hemodinamico. Conducta inicial: a. Pleurostomía

B) Reanimación
C) Pericardiocentesis yo puse pericardiocentesis, porque si es un NT a tensión necesita la punción con aguja antes q una pleurostomía
C) Laparotomía exploratoria
D) Cirugía laparoscópica
E) Manejo conservador

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Pericardiocentesis yo puse pericardiocentesis, porque si es un NT a tensión necesita la punción con aguja antes q una pleurostomía** (opción **C**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 52 4.01.2.016 · Traumatismo torácico grave

Un paciente de 23 años sufre una puñalada en región supraclavicular izquierda, dos días después consulta por disnea y tope inspiratorio. Al examen físico está en regulares condiciones y decaído, en su examen pulmonar se encuentra disminución del murmullo pulmonar izquierdo. Se solicita radiografía de tórax que es compatible con derrame pleural ipsilateral. Se realiza toracocentesis que da salida a líquido blanco. El diagnóstico más probable es:

A) Empiema
B) Derrame paraneumónico
C) Hemotórax
D) Quilotórax
E) Neumotórax

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Quilotórax de libro. Su primera causa es traumático. Además el ducto torácico está en el lado izquierdo

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 59 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asocia- do a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta do- lor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y to- nalidad, con blumberg presente. El diagnóstico más probable es:

A) Obstrucción intestinal
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Embolia mesenterica
D) Pancreatitis
E) Diverticulitis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Obstrucción intestinal** (opción **A**). Es una obstrucción intestinal clásica, probablemente por bridas (antecedente de cirugía).. Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 173 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Paciente con apendicectomía previa, ahora con dolor abdominal cólico, distensión progresiva y sin eliminación de gases ni heces. ¿Diagnóstico más probable?

A) Obstrucción intestinal por bridas
B) Vólvulo de colon sigmoide
C) Ileo paralítico postoperatorio
D) Hernia inguinal incarcerada
E) Cáncer de colon obstructivo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Obstrucción intestinal por bridas** (opción **A**). Obstrucción intestinal por bridas. Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 53 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un paciente de 38 años, con antecedente de cirugía bariátrica, consulta por dolor abdominal tipo cólico y vómitos de 10 horas de evolución, que inició al día siguiente de una gran ingesta de alcohol y alimentos. Refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico está adolorido, con FC: 106x', PA: 120/80 mmHg, T°: 37,6°C. El abdomen se aprecia distendido y es doloroso a la palpación, sin Blumberg. Se auscultan los ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad y bazuqueo. El diagnóstico más probable es:

A) Pancreatitis aguda
B) Embolia mesentérica
C) Úlcera gastroduodenal complicada
D) Colecistitis aguda
E) Obstrucción intestinal por bridas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una obstrucción intestinal clásica, cuya causa más frecuente son las bridas (en especial en pacientes con antecedente de cirugía abdominal previa).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 73 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Paciente de 68 años, sin antecedentes conocidos, consulta por cuadro de dolor abdominal desde hace 6 horas, asociado a distensión progresiva, vómitos y sensación febril, además refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico destaca ausencia de ruidos hidroaéreos y blumberg (+). Se solicita radiografía de abdomen que se muestra a continuación:

A) Gastroenteritis aguda
B) Vólvulo sigmoides
C) Obstrucción intestinal
D) Diverticulitis aguda
E) Apendicitis aguda

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se ven las asas dilatadas y tiene el cuadro clínico. No se ve la imagen de grano de café, como para haber pensado en vólvulo.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 128 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un paciente de 58 años presenta dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a náuseas y distensión abdominal. Sus últimas deposiciones fueron hace dos días y no ha eliminado gases por ano desde ayer. Sus signos vitales muestran T°: 36,8°C, FC: 96x', PA: 144/92 mmHg, abdomen distendido, doloroso a la palpación, con signo Blumberg esbozado. En la auscultación abdominal, tiene bazuqueo intestinal y disminución de los ruidos hidroaéreos. Como antecedentes médico-quirúrgicos, es diabético, usa metformina y aspirina y se realizó apendicectomía hace 10 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vólvulo de sigmoides
B) Isquemia mesentérica
C) Gastroenteritis aguda
D) Obstrucción intestinal
E) Cáncer de colon perforado

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Obstrucción intestinal** (opción **D**). Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 117 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un paciente de 40 años con antecedente de cirugía bariátrica presenta un cuadro de 24 horas de dolor abdominal muy intenso, tipo cólico, asociado a múltiples episodios de vómitos alimentarios. Al examen físico presenta T°: 38,5°C, frecuencia cardiaca regular a 108 lpm, presión arterial de 100/60 mmHg. Al examen abdominal, se observa abdomen distendido, doloroso a la palpación, con resistencia muscular difusa, se ausculta bazuqueo intestinal y ruidos hidroaéreos intensos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Íleo mecánico por bridas
B) Perforación intestinal
C) Isquemia mesentérica
D) Colitis isquémica
E) Gastroenteritis aguda

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Obstrucción Intestinal por Bridas: El paciente presenta un cuadro clínico de obstrucción intestinal, caracterizado por la tríada de dolor cólico, vómitos y distensión abdominal. En este caso, la causa más probable de la obstrucción son las bridas, debido al antecedente de cirugía abdominal previa.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 36 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un paciente de 56 años, con antecedente de enfermedad de Cröhn, desde los 26 años, sin tratamiento, desde hace 4 meses, presenta un cuadro de dolor abdominal y vómitos, que han ido en aumento. Sus vómitos son de tipo alimentario y al examen físico tiene PA: 110/70 mmHg, FC: 90 x', T°: 37°C, al examen abdominal se observa abdomen distendido, con auscultación de gorgoritmos y ruidos hidroaéreos intensos. Se solicita radiografía, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Cröhn activa
B) Apendicitis aguda
C) Perforación intestinal
D) Vólvulo de sigmoides
E) Obstrucción intestinal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una obstrucción intestinal clásica tanto por la imagen como por la clínica. En este caso, el antecedente de E. Cröhn sugiere que se complicó con una estenosis intestinal.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 46 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Pre unta 46 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 80 años, consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, tipo cólico, intenso, al que se han agregado vómitos alimentarios importantes. El dolor es más intenso en el hemiabdomen superior. Al examen físico se aprecia paciente adolorido, con PA: 110/68 mmHg, FC: 110x', T°: 37,4. Abdomen doloroso a la palpación, con distensión abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados y sin signos de irritación peritoneal. Se solicitan exámenes entre los que destaca PCR: 10 mg/dl, hematocrito: 37%, blancos: 11.000 por mm3, plaquetas: 340.000, GOT: 66 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Colitis isquémica
B) Trombosis de la vena mesentérica
C) Perforación gástrica
D) Pancreatitis aguda
E) Obstrucción intestinal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Obstrucción intestinal** (opción **E**). Tiene una obstrucción intestinal clásica.. Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 130 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un recién nacido de 4 semanas de vida presenta un cuadro de vómitos postprandiales abundantes, desde hace una semana, asociada a detención del incremento ponderal. La madre refiere que lo nota hambriento y toma leche ávidamente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar radiografía de abdomen simple
B) Realizar tratamiento endoscópico
C) Observar evolución
D) Realizar pilorotomía de Ramstedt
E) Realizar funduplicatura gástrica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene clínica de una estenosis hipertrófica del píloro. Por tanto lo más correcto era solicitar una ecografía abdominal, para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, de las opciones, la pilorotomía es el tratamiento de elección.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 175 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un niño de 48 horas de vida, con antecedente de Síndrome de Down, presenta vómitos alimentarios explosivos, asociados a irritabilidad y decaimiento. Al examen abdominal se palpa abdomen blando, doloroso, con distensión epigástrica, que desaparece después de vomitar. El diagnóstico más probable es:

A) Atresia esofágica
B) Hiperplasia suprarrenal congénita
C) Enterocolitis necrotizante
D) Atresia duodenal
E) Estenosis hipertrófica del píloro

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una atresia duodenal clásica, tanto por el antecedente de síndrome de Down, como por la clínica (vómitos precoces, dolor y distensión que ceden con los vómitos). La enterocolitis puede tener una clínica similar, pero suele tener distensión persistente y hemorragia. La estenosis hipertrófica suele aparecer después de las 2 semanas de vida, aunque su clínica puede ser igual.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 114 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Una lactante de 9 meses presenta dolor abdominal intenso, con llanto persistente y flexión de caderas. Presenta eliminación de deposiciones con abundante sangre. Se solicita radiografía abdominal, que resulta normal y ecografía abdominal, con imagen de "rosquilla". ¿Cuál es la medida terapéutica más adecuada?

A) Descomprensión neumática
B) Reducción manual quirúrgica abierta
C) Ablación endoscópica
D) Reducción laparoscópica
E) Resección quirúrgica por laparotomía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una invaginación intestinal clásica, con la confirmación ecográfica (imagen en dona, en tiro al blanco o en herradura), la que se trata con desinvaginación neumática y solo se opera si falla o si se complica con perforación.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 152 · 4.01.2.005 · Obstrucción Intestinal

Un lactante de 9 meses de edad presenta un cuadro de llanto y dolor abdominal de 10 horas de evolución, con flexión de las caderas, que luego se sigue de eliminación de sangre franca por el ano, cediendo el dolor. Se realiza una ecografía abdominal, que muestra una imagen en forma de dona. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Resección del segmento afectado por laparotomía
B) Reducción por laparoscopía
C) Colonoscopía
D) Reducción neumática
E) Observar evolución

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una intususcepción o invaginación intestinal. La reducción neumática es el tratamiento de elección. (pregunta para especialistas, no para médico general).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 83 4.01.1.049 · Trombosis venosa profunda

Una paciente de 25 años, es operada de apendicitis aguda hace 24 horas, actualmente se encuentra muy decaída y con dificultad respiratoria. Al examen físico destaca pálida, frecuencia cardiaca de 110 por minuto y con presión arterial de 90/60. El diagnóstico más probable es:

A) Atelectasia
B) Reacción adversa a medicamentos
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Infección de herida operatoria
E) Hemoperitoneo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Tromboembolismo pulmonar** (opción **C**). Por ser postQx es TEP y por el compromiso HDN es masivo probblemente. La trombosis venosa profunda (TVP) es una patología frecuente causada por la tríada de Virchow: hipercoagulabilidad, estasis venosa y daño endotelial. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 96 4.01.2.007 · Isquemia mesentérica aguda

Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdo- men doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombosis de la vena mesentérica
B) Hemoperitoneo
C) Úlcera péptica perforada
D) Embolia mesentérica
E) Aneurisma aórtico abdominal roto

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen di- chos signos.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 15 4.01.2.007 · Isquemia mesentérica aguda

Una mujer de 62 años acude al servicio de urgencia por dolor abdominal intenso, de dos horas de evolución, difuso, pero mayor en hemiabdomen superior. Además, presentó vómitos alimentarios, en varias oportunidades. El dolor inició tipo cólico, pero luego se hizo permanente. Al examen físico tiene IMC: 32, T°: 36,7°C, FC: 108x', PA: 102/96 mmHg. Examen cardiopumonar normal. El examen abdominal muestra cicatriz de cesárea Pfannestiel, timpanismo y disminución de la matidez hepática a la percusión y ruidos hidroaéreos muy disminuidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Obstrucción intestinal
B) Perforación intestinal
C) Vólvulo de sigmoides
D) Trombosis de la vena mesentérica
E) Embolia mesentérica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trombosis de la vena mesentérica** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 100 4.01.2.007 · Isquemia mesentérica aguda

Una paciente de 65 años, con antecedente de accidente vascular encefálico con compromiso faciobraquiocrural derecho hace dos años en tratamiento con aspirina, consulta por dolor abdominal difuso e intenso de inicio agudo. Al examen físico se encuentra en regulares condiciones, ritmo irregular, abdomen levemente doloroso a la palpación profunda, blumberg (-). El diagnóstico más probable es:

A) Isquemia mesentérica
B) Disección aórtica
C) Úlcera perforada
D) Diverticulitis aguda
E) Trombosis mesentérica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Isquemia mesentérica** (opción **A**). Tiene una embolia mesentérica, secundaria a la FA (ritmo irregular).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 143 4.01.1.051 · Pie diabético

Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primer ortejo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias
B) Angiografía
C) Amputación abierta
D) Amputación cerrada
E) Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una fasceítis necrotizante, sin compromiso óseo (no amputar). Si tuviera la osteomielitis, se amputa el pie diabético.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 154 4.01.2.019 · Perforación esofágica - Me

Paciente de 43 años, con historia de epigastralgia desde hace 3 semanas sin otros síntomas, como parte del estudio de su patología se realiza endoscopía digestiva alta que muestra gastritis erosiva, sin presencia de úlcera péptica activa y con test de ureasa positivo, por este motivo se indica tratamiento erradicador del helicobacter pylori. Tres horas luego del procedimiento, evoluciona con dolor torácico irradiado a hombro derecho y sensación febril. El examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso es:

A) Radiografía de tórax
B) Repetir endoscopía
C) Tomografía axial computada de tórax
D) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
E) Electrocardiograma

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Tomografía axial computada de tórax** (opción **C**). Sospecha de perforación esofágica iatrogénica, con mediastinitis secundaria. El TAC es el mejor examen.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 27 4.01.1.035 · Cáncer de mama

Una paciente de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indolora, de consistencia dura y adherida a planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hidrosadenitis
B) Cáncer de mama
C) Cáncer de pulmón
D) Lipoma
E) Tuberculosis ganglionar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El cáncer de mama es el que da metástasis gangionares a la axila con mayor frecuencia. Que sea indolora descarta hidrosadenitis. Lipoma es blando. TBC ganglionar es rara y suele tener una clínica más inflamatoria, con fistulización: sale caseum.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 178 4.01.1.035 · Cáncer de mama

Una paciente de 41 años, presenta un nódulo mamario derecho, de 2 cm de diámetro, que se autopalpó hace 2 meses. Al examen físico tiene consistencia dura e irregular. Cuenta con una mamografía, que es informada como Birrads 4. La conducta más adecuada es:

A) Controlar con nueva mamografía en 1 año
B) Solicitar ecotomografía mamaria
C) Solicitar resonancia magnética de mama
D) Realizar biopsia con aguja gruesa
E) Realizar biopsia estereotáxica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Birrads 4 se biopsia. Tanto aguja gruesa, como biopsia estereotáxica son respuestas aceptables. Sin embargo, la biopsia estereotáxica suele ser mas fidedigna.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 153 4.01.1.035 · Cáncer de mama

Una mujer de 45 años se realiza una mamografía, que muestra microcalcificaciones agrupadas y espiculadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, de 2 cm de diámetro. Su examen mamario no tiene alteraciones y cuenta con una mamografía previa, de hace 2 años, informada como Birrads 2. La conducta más adecuada es:

A) Pedir ecotomografía mamaria
B) Realizar biopsia con aguja gruesa
C) Programar biopsia estereotáxica
D) Solicitar resonancia magnética mamaria
E) Realizar control mamográfico en un año

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una lesión sospechosa, que actualmente es Birrads 4 a 5 (microcalcificaciones agrupadas y espiculadas). Si alguien leyó a la rápida, se quedó con la idea de que era Birrads 2, pero esa es la mamografía antigua. La forma de biopsiar suele ser aguja gruesa, si es que el nódulo mamario es palpable y por biopsia estereotáxica, cuando no lo es (como en este caso, que se describe que el examen mamario es normal).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 173 4.01.1.035 · Cáncer de mama

Una mujer de 52 consulta por molestias en la mama izquierda de 4 meses de evolución, caracterizados por eritema y prurito en el pezón y la aréola. Al examen físico se ve lo siguiente (Nota: aréola y pezón están eritematosos): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Paget de la mama
B) Mastitis candidiásica
C) Cáncer inflamatorio de la mama
D) Papiloma del pezón
E) Eccema del pezón

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Paget de la mama** (opción **A**). El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile, seguido del cáncer gástrico y de pulmón. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 90 4.01.1.055 · Abscesos, forúnculos, pana

Un paciente de 28 años tiene un quiste epidérmico en el cuello y consulta porque ahora aumentó de volumen y se ha vuelto doloroso y eritematoso. Al examen físico se lo aprecia según la imagen: FOTO (absceso en el cuello, con algo de eritema alrededor y se ve de aspecto amarillo). La conducta más adecuada es:

A) Observar evolución
B) Indicar corticoides tópicos
C) Indicar antibióticos más drenaje quirúrgico
D) Realizar resección quirúrgica del quiste
E) Puncionar la lesión

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un quiste epidérmico abscedado, lo que se trata con antibióticos (antiestafilocócicos: ej. cloxacilina) más drenaje quirúrgico. Eventualmente, el quiste sí se debe resecar, pero no mientras está infectado.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 28 4.01.1.055 · Abscesos, forúnculos, pana

Un paciente alcohólico, de 50 años, en situación de calle, consulta por dolor en el antebrazo derecho, muy intenso. Al examen físico se aprecia una lesión grande en el antebrazo derecho, con áreas violáceas, que crepita a la palpación. Su frecuencia cardiaca es de 108x`, con PA: 90/60 mmHg y su hemograma muestra leucocitosis de 17.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Loxocelismo cutáneo
B) Celulitis
C) Úlcera por presión
D) Fascitis necrosante
E) Miositis necrosante

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fascitis necrosante** (opción **D**). El dolor, las flictenas, las áreas necroticas y la crepitación orientan a fasceítis.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 30 · 4.01.5.017 · Hemostasia con ligaduras y

Un paciente de 28 años sufre un accidente con un vidrio, resultando con una herida cortante en el muslo izquierdo, de 10 cm de largo, que sangra profusamente. ¿Cuál es la mejor forma de manejar la hemorragia?

A) Aplicación de torniquete
B) Compresión directa de la herida
C) Identificar y ligar el vaso sanguíneo sangrante
D) Compresión de la arteria femoral
E) Cubrir la herida con apósitos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Compresión directa de la herida). Las heridas que sangran se comprimen directamente. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 31 · 4.01.2.010 · Trauma abdominal abierto y

Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
B) Realizar ecografía fast
C) Suturar la herida
D) Solicitar TAC abdominal
E) Realizar laparoscopía exploradora

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una herida penetrante abdominal (lacera el peritoneo). La mayoría de los autores recomienda explorar, idealmente por laparoscopía. De todos modos algunos recomiendan hacer EcoFast si está en tan buenas condiciones y tiene buena evolución (como es este caso). No es un tema cerrado, sino controvertido.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 33 · 4.01.2.008 · Enfermedad diverticular co

Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa iliaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda
B) Cáncer de colon
C) Obstrucción intestinal
D) Diverticulitis aguda
E) Hernia inguinal complicada

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Diverticulitis aguda** (opción **D**). Cuadro clásico. El cuadro clínico de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda ("apendicitis izquierda"), fiebre y leucocitosis en un paciente adulto mayor o con constipación crónica configura la presentación clásica de diverticulitis aguda (enfermedad diverticular complicada). El examen confirmatorio de elección es la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis con contraste.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 39 · 4.01.4.002 · Radiografía simple de abdo

Se muestra la siguiente radiografía: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer pulmonar
B) Neumoperitoneo
C) Signo de Chilaiditi
D) Absceso pulmonar
E) Quiste hidatídico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

foto clásica. El signo de Chilaiditi tiene el colon sobre el hígado, pero se ve con haustras y en la foto no se veían.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 123 · 4.01.3.005 · Complicaciones postoperato

Un paciente de 17 años, apendictomizado hace 6 horas, evoluciona con malestar general y dolor abdominal intenso. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto, su presión arterial es 90/50 mmHg y su temperatura es 37,7ºC. En el examen abdominal presenta dolor a la palpación profunda y superficial, con signos peritoneales difusos, mayores en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:

A) Hemoperitoneo
B) Evisceración
C) Trombosis de la vena porta
D) Dehiscencia de la base apendicular
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El hemoperitoneo es muy raro y se presenta con compromiso hemodinámico y palidez y luego, más tarde presenta dolor abdominal e incluso signos peritoneales difusos. Sin embargo, la dehiscencia presenta una clara peritonitis, con dolor, signos peritoneales localizados y luego difusos, fiebre y luego shock hipovolémico y séptico; es mucho más frecuente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 11 · 4.01.3.005 · Complicaciones postoperato

Una paciente de 48 años, se somete a una gastrectomía total. Al segundo día postoperatoria presenta fiebre y taquicardia, con FC: 100x' y PA: 140/90. Al examen físico presenta herida operatoria sin alteraciones, con abdomen sensible a la palpación. El examen pulmonar muestra hipoventilación basal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

A) Infección urinaria
B) Filtración de la anastomosis
C) Reacción adversa a medicamentos
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Atelectasia infectada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta capciosa, con redacción insuficiente. Las atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria (en especial en las primeras 48 horas) y además la hipoventilación basal la sugiere. Sin embargo, no necesariamente está infectada. Además, el cuadro también podría calzar con un TEP, por el tiempo de evolución y por la taquicardia, aunque falta información (ej. inicio súbito, desaturación arterial, etc.). Además, siempre que se pregunta algo así, lo importante es descartar el TEP, el que se pregunta siempre y de manera muy inespecífica: “paciente con antecedente de un factor de riesgo de TEP, que le pasa cualquier cosa compatible con un TEP”. La única razón por la cual se elige la atelectasia es porque preguntan dirigidamente por la causa de fiebre.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 173 · 4.01.3.005 · Complicaciones postoperato

Un paciente de 46 años se realiza una colecistectomía abierta. A las 48 horas presenta fiebre de 37,8°C. Al examen físico está eupneico, FR: 14x', FC: 78x', PA: 120/80 mmHg, satura 98% a FiO2 ambiental. Se aprecia herida operatoria sin eritema ni secreción y se revisan las vías venosas, que están permeables, sin signos inflamatorios. Su examen pulmonar presenta crépitos localizados en la base derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumonía
B) Dehiscencia de la anastomosis
C) Atelectasia
D) Infección de la herida operatoria
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las atelectasias son la causa más frecuente de fiebre postquirúrgica en las primeras 48 horas. Los crépitos también la sugieren. La neumonía sí tiene crépitos localizados y fiebre, pero le falta la tos y expectoración mucopurulenta. El TEP puede tener esa clínica, pero suele tener taquicardia o síntomas respiratorios de inicio súbito. La dehiscencia de la anastomosis produce una peritonitis aguda.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 68 · 4.01.3.005 · Complicaciones postoperato

Un paciente se realiza una cirugía abdominal. Usted lo evalúa a las 24 horas y obser- va que la herida operatoria presenta abundante secreción serohemática, con depresión de la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hernia umbilical
B) Eventración
C) Seroma
D) Evisceración
E) Infección de la herida operatoria

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Seroma** (opción **C**). La descripción era muy pobre, pero seroma era lo más aceptable (aunque llevaba poco tiempo).. La fiebre postquirúrgica es una complicación frecuente y potencialmente grave que requiere identificar su causa para tratarla adecuadamente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 40 · 4.01.3.005 · Complicaciones postoperato

Un paciente es sometido a una ccolecistectomía y a las 24 horas presenta fiebre hasta 38,3 grados celsius. Su examen físico muestra un paciente ferbil, con crepitaciones en la base pulmonar derecha, asociado a roncus. Tiene vías venosas in situ, sin eritema y su herida quirúrgica está cerrada, sin exudado ni eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumonía
C) Atelectasia
D) Infección de la herida operatoria
E) Infección asociada a catéter

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria en las primeras 24 horas y la clínica es absolutamente concordante (crepitaciones localizadas, etc).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 41 · 4.01.1.017 · Abscesos y fístulas ano re

Un hombre de 60 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de 4 cm de diámetro, dolorosa a la palpación, fluctuante, con signos inflamatorios. El tratamiento más adecuado es:

A) Curación plana
B) Drenaje quirúrgico
C) Antibióticos orales
D) Punción y drenaje
E) Analgésicos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Drenaje quirúrgico** (opción **B**). Probable absceso perianal. Debe ser drenado en pabellón.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 50 · 4.01.1.036 · Patología mamaria benigna

Un paciente de 35 años presenta un nódulo mamario, desde hace 8 meses. Su ecografía mamaria muestra un tumor de aspecto sólido, bordes bien delimitados, sin refuerzo posterior y con un índice ultrasonográfico Birrads 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Mastopatía fibroquística
B) Papiloma ductal
C) Fibroadenoma
D) Tumor phylloides
E) Carcinoma ductal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un fibroadenoma clásico. Se sigue con ecografía cada 6 meses por 2 años. Se ve sólido, hipoecogénico, con bordes bien definidos, habitualmente con forma oval y orientación horizontal. Suele no tener sombra ni refuerzo posterior.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 176 · 4.01.1.036 · Patología mamaria benigna

Una mujer de 22 años consulta por un nódulo mamario, que se autopalpó. Al examen físico se constata un nódulo en la mama derecha, de 2 cm de diámetro, móvil. No se palpan adenopatías axilares. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

A) Mamografías
B) Ecografía mamaria
C) Resonancia magnética nuclear de mamas
D) TAC de tórax
E) Biopsia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Ecografía mamaria). Es un fibroadenoma clásico, que se estudia con ecografía mamaria.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 7 4.01.1.036 · Patología mamaria benigna

Una paciente de 30 años, con antecedente de un quiste mamario izquierdo, consulta por dolor en la mama izquierda, asociada a fiebre y eritema. Al examen físico se constata eritema, aumento de volumen y dolor en la mama izquierda, con un nódulo doloroso a la palpación. Se solicita una ecografía que muestra una imagen quística de 5 cm de diámetro, con signos inflamatorios en las partes blandas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar seguimiento ecográfico
B) Iniciar tratamiento con AINES
C) Realizar punción y drenaje
D) Drenar mediante cirugía
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un absceso mamario, que se debe drenar en pabellón. Además, se deben dar antibióticos (cloxacilina o cefazolina). En cambio, el flegmón mamario y las mastitis no abscedadas, solo se tratan con antibióticos.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 155 4.01.1.036 · Patología mamaria benigna

Mujer joven con nódulo mamario de 5 cm, móvil, blando, sensible. Ecografía BIRADS-US 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Biopsia core guiada por ecografía
B) Ecotomografía de control en 6 meses
C) Mamografía bilateral
D) Resonancia magnética mamaria
E) Exéresis quirúrgica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ecotomografía de control en 6 meses** (opción **B**). Ecotomografía de control en 6 meses. Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 45 4.01.1.036 · Patología mamaria benigna

Una paciente de 31 años, puérpera de 10 días, consulta por dolor y aumento de volumen en la mama derecha. Al examen Fsico, presenta mamas conges8vas, y la mama derecha se observa con eritema más una masa fluctuante y dolorosa de 6 cm de diámetro, con afectación de la piel y secreción purulenta que sale por la lesión cutánea a la compresión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) An2bió2cos de amplio espectro por vía oral
B) Realizar drenaje quirúrgico de la lesión
C) Realizar drenaje por punción
D) Realizar extracción láctea
E) Aplicar calor local y an2inflamatorios orales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un absceso mamario. Hasta hace poco se diagnosticaban principalmente con la clínica y se drenaban con cirugía. Sin embargo, recomendaciones más actuales recomiendan estudiarlas con una ecografía mamaria y drenarlos por punción. El drenaje por incisión (quirúrgico) sigue siendo de elección cuando hay necrosis cutánea (como en este caso) y cuando falla o no está disponible el drenaje por punción.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 77 4.01.1.036 · Patología mamaria benigna

Una paciente de 25 años, con antecedente de un quiste mamario de dos centímetros, en la mama derecha, diagnosticado hace 2 años. Consulta ahora por dolor y aumento de volumen, en relación a la mama derecha. Al examen físico tiene fiebre de 38,6°C, más una zona aumentada de volumen, con eritema y aumento de la temperatura, en la mama derecha, mayor en la zona superoexterna. Se solicita una ecografía mamaria, que visualiza signos inflamatorios de las partes blandas, más la lesión quística de 5 cm de diámetro, con contenido irregular. La conducta más adecuada es:

A) Punción del quiste
B) Solicitar resonancia magnética de mama
C) Drenaje quirúrgico
D) Realizar biopsia con aguja gruesa
E) Control mamográfico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un absceso mamario, como complicación de un quiste infectado. Se debe drenar y manejar con antibióticos. El drenaje es quirúrgico, con incisión y drenaje.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 21 4.01.1.036 · Patología mamaria benigna

Paciente femenina de 35 añoos, quien evidencia masa en cuadrante superoexterno de mama izquierda, no doloroso, de consistencia lisa y no adherido a planos profundos. Tiene una tía fallecida de cáncer de mama a los 71 años y usa anticonceptivos orales. La conducta más apropiada es:

A) Realizar ecotomografía de mamas
B) Realizar mamografía
C) Punción con aguja fina
D) Realizar tumorectomía y biopsia
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un fibroadenoma, que se estudia con ecografía. Además, las mamografías suelen ser poco útiles antes de los 40 años. Sin embargo, si la clínica no hubiese sido tan sugerente de fibroadenoma, sino de otras cosas (ejemplo nódulo mamario inespecífico o cáncer), el examen de elección sí sería la mamografía (se pide desde los 40 años, cada 1 a 2 años y se pide antes, si es que hay nódulos palpables). La ecografía, en cambio, es de elección es: 1. el embarazo, 2. mamografía Birrads 0, 3. clínica de fibroadenoma y 4. Clínica de quiste o mastopatía fibroquística.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 68 4.01.2.006 · Apendicitis aguda

Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura: 38,7 grados, FC: 100x', PA: 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio; 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva: 15. El diagnóstico más probable es:

A) Pielonefritis aguda
B) Apendicitis aguda
C) ITU baja
D) Torsión ovárica
E) Plastrón apendicular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Apendicitis aguda** (opción **B**). Es una apendicitis clásica.. La cronología de Murphy (dolor periumbilical migrado a fosa ilíaca derecha) junto a signos de irritación peritoneal focal (Blumberg, McBurney) y fiebre orienta con alta especificidad a apendicitis aguda. En varones jóvenes con cuadro típico se procede a apendicectomía directa.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 62 4.01.2.006 · Apendicitis aguda

Una mujer de 25 años consulta por dolos abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca derecha y en el hipogastrio, EVA 8/10. Al examen físico tiene FC: 90x', PA: 110/70 y el examen abdominal muestra abdomen blando y depresible, pero doloroso a la palpación de ambas fosas ilíacas. Dos horas después del ingreso a la sala de urgencia, presenta deterioro marcado del estado general, objetivándose que su frecuencia cardíaca de 120x' y presión arterial de 80/40 mmHg. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda
B) Perforación intestinal
C) Torsión ovárica
D) Absceso tubo ovárico roto
E) Embarazo ectópico roto

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Apendicitis aguda** (opción **A**). La cronología de Murphy (dolor periumbilical migrado a fosa ilíaca derecha) junto a signos de irritación peritoneal focal (Blumberg, McBurney) y fiebre orienta con alta especificidad a apendicitis aguda. En varones jóvenes con cuadro típico se procede a apendicectomía directa.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 89 4.01.1.019 · Cáncer anal

Un paciente de 45 años, diagnosticado de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico, se observa lesión solevantada en los margenes anales, de 4 cm, que se introduce en el recto, sobrepasando la línea pectínea, con una con una ulceración central, con escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:

A) Hemorroide externa trombosado
B) Condiloma acuminado
C) Sífilis
D) Cáncer epidermoide
E) Enfermedad de Cröhn

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un cáncer de recto, que aumenta el riesgo en el paciente VIH, en especial con VPH de alto riesgo (serotipos 16 y 18).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 136 4.01.1.019 · Cáncer anal

Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH, consulta por una le- sión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 4 cm de diámetro, bordes cartográ- ficos y que se introduce por el ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sífilis
B) Enfermedad de Cröhn
C) Carcinoma epidermoide
D) Melanoma
E) Tuberculosis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Carcinoma epidermoide** (opción **C**). Es un cáncer de recto clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 90 4.01.5.018 · Intubación traqueal

Cuando se realiza una intubación orotraqueal en un paciente que se esta reanimando, ¿cuál es la conducta es parámetro ideal para confirmar que está adecuadamente intubado?

A) Pulsometría
B) Auscultación pulmonar
C) Capnografía
D) Oximetría
E) Expansión torácica SEGUNDA PARTE

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La capnografía es de elección actualmente para confirmar la intubación traqueal y descartar la intubación esofágica (mide CO2, que seguramente viene de los pulmones). Eso sí, la clínica, en especial la auscultación, sigue siendo un buen indicador. PARTE 2

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 105 4.01.5.018 · Intubación traqueal

Paro, en una reanimación, en condiciones idóneas como verifico que una IOT está bien hecha a. Capnografia

B) Auscultación pulmonar
C) Saturación de o2
D) Expansión torácica
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Auscultación pulmonar, Saturación de o2) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 101 4.01.1.054 · Tumores malignos de partes

Un paciente de 18 años, consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto dolorosa. Al examen físico se palpa una masa de 10 cm de diámetro, de consistencia dura, no pétrea, sin afectación de la piel. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar resección y biopsia
B) Observar evolución
C) Solicitar ecografía de partes blandas
D) Solicitar radiografía de fémur
E) Realizar punción y drenaje

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un probable sarcoma de partes blandas. Debe estudiarse con resonancia magnética nuclear, como examen de elección, para determinar el grado de invasión, antes de definir qué tipo de cirugía se le hará. Como no aparecía en las opciones, lo más razonable es hacer la ecografía, porque al menos es suficiente para distinguir entre un tumor benigno y uno maligno. Luego sí se hará la resección y biopsia.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 116 4.01.1.032 · Masa cervical y tumores de

Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulo tiroideo
B) Quiste branquial
C) Quiste tirogloso
D) Linfadenopatía tuberculosa
E) Tumor de glándula salival secundaria

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 80 4.01.1.032 · Masa cervical y tumores de

Adulto joven con masa blanda palpable entre el mentón y el cartílago tiroides. ¿Diagnóstico más probable?

A) Adenoma tiroideo
B) Quiste tirogloso
C) Quiste branquial
D) Linfadenitis cervical
E) Lipoma cervical

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Quiste tirogloso** (opción **B**). Quiste tirogloso. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 47 4.01.1.032 · Masa cervical y tumores de

Niño de 4 años con masa cervical anterior en la línea media, móvil con la deglución y la protrusión de la lengua, sin dolor ni fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

A) Quiste tirogloso; derivar a cirugía para extirpación electiva
B) Adenopatía cervical reactiva; observar
C) Linfoma cervical; biopsia
D) Bocio difuso; solicitar TSH
E) Quiste braquial; observar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Masa cervical anterior en línea media que sube con deglución y protrusión lingual = quiste tirogloso. Tratamiento: cirugía de Sistrunk (extirpación del quiste + cuerpo del hioides) para evitar recidivas.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 164 4.01.1.032 · Masa cervical y tumores de

Un niño de 5 años presenta aumento de volumen de 4 cm de diámetro, doloroso, eritematoso y consistencia fluctuante, en relación al hueso hiodes, de 3 días de evolución, con sensación febril. El diagnóstico más probable es:

A) Quiste tirogloso infectado
B) Quiste branquial infectado
C) Quiste dermoides infectado
D) Absceso simple de cuello
E) Adenitis supurativa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Solo por la ubicación (línea media: hueso hioides) se trata de un QTG. Lo demás simplemente muestra signos de infección, compatibles con todas las opciones.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 156 4.01.3.012 · Diagnóstico precoz del cán

Mujer con microcalcificaciones agrupadas en mamografía (no palpables, no visibles en ECO), BIRADS-4. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Seguimiento mamográfico en 6 meses
B) Ecografía mamaria dirigida
C) RNM mamaria bilateral
D) Cuadrantectomía diagnóstica
E) Biopsia estereotáxica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Biopsia estereotáxica** (opción **E**). Biopsia estereotáxica. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 134 4.01.3.012 · Diagnóstico precoz del cán

Una mujer de 55 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4, con microcalcificaciones agrupadas. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

A) Ecotmografía mamaria
B) Biopsia estereotáxtica.
C) Resonancia magnética
D) Control mamográfico en 6 meses
E) mastectomía parcial

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Birrads 4 = biopsia histológica. Birrads 0 = Ecografía; Birrads 1 y 2 = control en 1 año con mamografía; Birrads 3 = control con mamografía en 6 meses y además esposible complementar con Eco. Birradas 5 = biopsia quirúrgica.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 61 · 4.01.3.012 · Diagnóstico precoz del cán

Una paciente de 52 años, cuya tía fue diagnosticada de cáncer de mama, se realiza una mamografía de control, que muestra microcalcificaciones agrupadas, localizadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, informándose como Bi-Rads 4. La inspección y palpación mamaria son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar biopsia por punción con aguja gruesa
B) Solicitar biopsia estereotáxica
C) Solicitar ecografía mamaria
D) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas
E) Derivar para cirugía mamaria a la brevedad

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Derivar para cirugía mamaria a la brevedad** (opción **E**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 95 · 4.01.1.028 · Cáncer de vesícula y vías

Una paciente de 60 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva, por una colelitiasis. La biopsia es informada como presencia adenocarcinoma invasor en el fondo de la vesícula, subseroso. Se solicta un TAC de abdomen y pelvis con contraste, que no visualiza metástasis. ¿Cuál es la conducta?

A) Quimioterapia
B) Radioterapia
C) Cuidados paliativo
D) Control con TAC cada 3 meses
E) Colecistectomía radical

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Lo correcto es hacer una cirugía abierta, con cuña hepática y linfadenectomía y no una colecistectomía radical, ya que la vesícula ya se extirpó. Sin embargo, de las alternativas que había, era la más aceptable.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 124 · 4.01.2.014 · Heridas de cara

Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Afrontamiento con cianoacrilato
B) Afrontamiento con tela adhesiva
C) Sutura con punto separado
D) Sutura intradérmica
E) Dejar que cure por segunda intención

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien también se puede afrontar con punto separado, en pediatría y también en adultos, se prefiere la sutura intradérmica para las heridas grandes de la cara, por su mejor resultado estético.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 43 · 4.01.1.018 · Enfermedades del seno pilo

Una paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso, en la zona interglútea, ubicado a dos centímetros de la línea media, sobre el coxis. Al examen físico, se observa aumento de volumen de 5 cm, doloroso, con presencia de dos orificios negros en la piel, cerca de la lesión. El diagnóstico más probable es:

A) Linfoma
B) Sarcoma
C) Quiste pilonidal
D) Absceso anorrectal
E) Lipoma

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Quiste pilonidal** (opción **C**). La patología pilonidal abarca varias condiciones ubicadas en la zona sacrococcígea. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 19 · 4.01.1.018 · Enfermedades del seno pilo

Un paciente de 47 años, obeso, consulta por dolor y aumento de volumen en la zona interglútea. Al examen físico se aprecia aumento de volumen en la zona sacra, de con- sistencia balnda, eritematoso y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

A) Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local
B) Antibióticos orales
C) Solicitar una ecografía de partes blandas
D) Solicitar resonancia nuclear magnética de pelvis
E) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local** (opción **A**). Es un quiste pilonidal infectado. Se debe drenar. Si no se infecta, solo se observa.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 77 · 4.01.1.018 · Enfermedades del seno pilo

Absceso interglúteo 2 cm, paciente BEG, cual es la conducta:

A) ATB
B) Drenar
C) Marsupialización
D) Staphylococcus aureus
E) Streptococcus pneumoniae

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Drenar** (opción **B**). El absceso pilonidal se drena y se indica antibiótico; si recurre se extirpa el quiste completo para tratamiento definitivo. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 26 · 4.01.1.048 · Várices. Insuficiencia ven

Mujer de 45 años con várices en extremidades inferiores bilaterales, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Anticoagulación oral
B) Flebectomía inmediata
C) Escleroterapia de urgencia
D) Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias compresivas
E) Derivación vascular urgente

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Varices simples sin complicaciones: manejo inicial conservador con elevación de extremidades, ejercicio (caminata), control de peso y medias de compresión elástica. La cirugía/escleroterapia se reserva para cuando las medidas conservadoras fallan o hay complicaciones.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 26 · 4.01.1.048 · Várices. Insuficiencia ven

Una paciente de 67 años, con antecedente de várices en las piernas con indicación de cirugía, presenta rotura de una de las várices, luego de un traumatismo en la pierna derecha, que produce sangramiento abundante. Al examen tiene FC: 80 latidos por mi- nuto, PA: 120/80 mmHg y se aprecia sangrado profuso del várice roto, en el tercio medio de la pierna. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Torniquete inframaleolar
B) Ligadura del cayado de la safena interna
C) Sutura del várice sangrante
D) Escleroterapia variceal
E) Safenectomía de urgencia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Várice sangrante con hemorragia profusa: el tratamiento inicial es la compresión directa (sutura del várice) y elevación de la extremidad. (Nota: el autor de la pauta señala que la pregunta excede conocimientos de médico general y que 'lo más correcto es comprimir el várice sangrante, elevar la extremidad'.)

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 54 · 4.01.1.020 · Fisura anorectal

Un paciente de 54 años consulta por dolor anal, que se presenta al defecar, persis- tiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones además ha presentado sangre en las deposiciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hemorroide externo trombosado
B) Cáncer de recto
C) Fisura anal
D) Fístula anal
E) Absceso perianal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fisura anal** (opción **C**). Fisura anal clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 65 · 4.01.2.022 · Aneurisma de aorta abdomin

Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertesión ar- terial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diáme- tro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombosis mesentérica
B) Tumor de colon
C) Tumor de páncreas
D) Disección aórtica
E) Aneurisma aórtico abdominal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Aneurisma aórtico abdominal** (opción **E**). Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA.. El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una dilatación permanente de la aorta abdominal mayor a 3 cm o 1,5 veces el diámetro normal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 86 · 4.01.2.022 · Aneurisma de aorta abdomin

Un paciente de 41 años, con antecedente de riñón poliquís8co del adulto, acude al servicio de urgencia por dolor epigástrico intenso asociado a malestar general. Al examen Fsico presenta frecuencia cardíaca 105 por minuto, presión arterial 90/60 mmHg, temperatura 36,2 °C y examen abdominal con abdomen depresible, con presencia de signos peritoneales esbozados en abdomen superior. Se palpan masas en ambos flancos y en el epigastrio. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran amilasa 160 U/L (valor normal 60 - 140 U/L), glicemia 110 mg/dL, GOT 50 U/L, crea8nina: 2,5 mg/dL, BUN: 48 mg/dL y troponinas nega8vas. ¿Cuál es el examen imagenológico de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Ecogra:a abdominal
B) PieloTAC
C) UroTAC
D) Ecocardiogra:a transesofágica
E) Resonancia magné2ca nuclear de abdomen

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, pero el diagnóstico de sospecha es una aneurisma aórtico abdominal (AAA) roto. El examen inicial es la ecografía abdominal de urgencia. El AAA se asocia a RPQ. La masa epigástrica es el AAA y las masas en ambos flancos son los riñones aumentados de tamaño por la enfermedad poliquística. El RPQ también se asocia a disección aórtica (se estudiaría con ecocardiografía transesofágica), pero, su cuadro clínico es disGnto, con dolor torácico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 55 · 4.01.1.008 · Cáncer gástrico

Un paciente de con antecedente de cáncer gástrico avanzado, con metástasis hepáticas múltiples y adenopatías perigástricas, consulta por cuadro de vómitos postprandiales intensos, que han ido en aumento y actualmente dificultan mucho la alimentación. Al examen físico está muy enflaquecido, con ausencia de grasa y con edema de extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Instalar sonda nasogástrica
B) Indicar nutrición parenteral total
C) Realizar radioterapia de urgencia
D) Realizar gastrectomía paliativa
E) Realizar derivación gastrointestinal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La derivación gastroyeyunal es menos agresiva que la hgastrectomía y permite retablecer el tránsito gastrointestinal.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 143 · 4.01.1.043 · Síndrome de ocupación pleu

Un paciente de 19 años consulta por dolor torácico derecho, de 24 horas de evolución, que aumenta con la inspiración. Al examen físico, se aprecia disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Foto 13 (https://imgur.com/gallery/U6p0b/comment/113820836) (La foto fue ennegrecida, para que se pareciera a las del Eunacom real, impreso). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control radiológico en 24 horas
B) Solicitar TAC de tórax
C) Realizar cirugía abierta
D) Drenaje con tubo pleural
E) Videotoracoscopía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por la clínica era un neumotórax. La radiografía era muy oscura, pero con imaginación y paciencia, se veía el neumotórax derecho (acá se ve más que en el real). Por ser mayor a 15%, se trata con tubo pleural.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 144 · 4.01.1.021 · Hernias, eventraciones y e

Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es dolorosa y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Linfoma
B) Hernia inguinal
C) Adenopatía metastásica
D) Hernia femoral
E) Sarcoma de partes blandas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hernia femoral** (opción **D**). Es una hernia femoral clásica (bajo el ligamento inguinal). Es más frecuente en mujeres.. Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 148 · 4.01.2.024 · Hemorragia aguda post oper

Un paciente, apendictomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto y su presión arterial es 90/50 mmHg. En el examen abdominal presenta dolor y signos peritoneales en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:

A) Hemoperitoneo
B) Evisceración
C) Trombosis de la vena porta
D) Dehiscencia de la base apendicular
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
[Pregunta disputada] Es una pregunta difícil, ya que el compromiso hemodinámico y los signos peritoneales pueden corresponder tanto a un hemoperitoneo, como a la dehiscencia de la base apendicular. Sin embargo, por predominar el compromiso hemodinámico, nos inclinamos a marcar hemoperitoneo. Si, en cambio, hubiese tenido predominancia de los signos peritoneales, nos habríamos inclinado a la dehiscencia.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 87 · 4.01.2.024 · Hemorragia aguda post oper

Un paciente de 42 años, con diagnós8co de hernia inguinal derecha, es some8do a hernioplas`a a las 8:00 horas del día de hoy. Evoluciona favorablemente en el postoperatorio inmediato y es dado de alta a las 15:00 horas. Reingresa a las 21:00 horas al servicio de urgencia por dolor intenso en la zona, EVA 7/10. Al examen Fsico, sus signos vitales muestran temperatura 37,1 °C, frecuencia cardíaca 100 por minuto y presión arterial 120/78 mmHg; se aprecia aumento de volumen inguinal doloroso a la palpación, con eritema de la piel. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Absceso inguinal
B) Hematoma inguinal
C) Hernia crural atascada
D) Cuerpo extraño
E) Recurrencia de la hernia inguinal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El diagnóstico más probable es un hematoma inguinal postoperatorio, dado el inicio precoz del dolor y aumento de volumen pocas horas después de la hernioplasVa. La presencia de eritema local puede explicarse por inflamación secundaria a la colección hemática. Los abscesos y la reacción inflamatoria al cuerpo extraño suelen presentarse de forma más tardía.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 6 · 4.01.5.021 · Manejo de drenajes

Un paciente de 76 años, con antecedente de accidente vascular secuelado, hace 2 meses, se alimenta mediante gastrostomía, la cual fue realizada endoscópicamente. Accidentalmente se retiró la sonda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar radiografía de abdomen simple
B) Solicitar ecografía abdominal
C) Solicitar TAC de abdomen
D) Instalar una nueva sonda por el ostoma
E) Realizar una nueva gastrostomía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy discutible y fuera de lo que debe hacer un médico general. Sin embargo, si es que la sonda se retiró, sin mayor daño, ni signos clínicos de perforación o filtración, se puede volver a instalar una nueva.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 112 · 4.01.1.012 · Megacolon

Un recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además, presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Al examen tiene ano permeable y se realiza un enema baritado, que muestra colon proximal dilatado y colon distal estrecho. El examen más adecuado para confirmar el diagnóstico es:

A) TAC abdominal
B) Colonoscopía
C) Test del sudor
D) Biopsia por succión
E) Cariograma

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se sospecha una enfermedad de Hirschsprüng, que se diagnostica con la biopsia intestinal, que muestra aganglionosis del plexo submucoso o mientérico, en el segmento afectado.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 75 4.01.1.060 · Obesidad mórbida

Una paciente de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace un año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer. El diagnóstico más probable es:

A) Hipoglicemias reactivas
B) Síndrome de dumping
C) Hernia del espacio de Petersen
D) Estenosis de la anastomosis
E) Déficit de vitamina B12

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome de dumping clásico (aprender dicha clínica), frecuente complicación de un by-pass gástrico. Se caracteriza por síntomas disautonómicos, que pueden ser muy similares a una hipoglicemia, por lo que siempre se debe solicitar HGT para descartarla. Sin embargo, la diarrea no calza con hipoglicemia, sino solo con dumping.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 169 4.01.2.003 · Peritonitis

Una paciente de 43 años, multípara, presenta dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Al examen, tiene FC: 110x', PA: 100/60 mmHg y al examen abdominal se observa cicatriz de cesárea Pfannestiel, y se palpa abdomen muy doloroso tanto a la palpación superficial como profunda, con distensión de la pared abdominal, pérdida de la matidez hepática a la percusión y abolición de los ruidos hidroaéreos a la auscultación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Obstrucción intestinal
B) Pancreatitis aguda
C) Perforación intestinal
D) Megacolon
E) Embolia mesentérica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La pérdida de la matidez hepática sugiere un neumoperitoneo, secundario a una perforación. También tiene clínica de la peritonitis secundaria: abolición de RHA, dolor intenso.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 162 4.01.2.003 · Peritonitis

Un paciente de 43 años presenta dolor epigástrico urente, de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve difuso y persistente, agregándose distensión abdominal. Al examen, tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg y al examen abdominal se observa abdomen doloroso y distendido, con pérdida de la matidez hepática y abolición de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Obstrucción intestinal
B) Pancreatitis aguda
C) Perforación de úlcera péptica
D) Plastrón vesicular
E) Cáncer de vesícula

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene toda la clínica de una úlcera perforada. De hecho, comienza con la clínica de una úlcera activa (epigastralgia urente que mejora con la ingesta) y luego el dolor intenso, con un íleo paralítico (distensión y RHA abolidos) por la peritonitis, más los signos de neumoperitoneo (pérdida de la matidez hepática).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 174 4.01.2.003 · Peritonitis

Paciente con distensión abdominal progresiva, dolor cólico, sin gases, dolor epigástrico, cicatriz de Pfannenstiel y pérdida de matidez hepática. ¿Diagnóstico más probable?

A) Obstrucción intestinal por adherencias
B) Vólvulo cecal agudo
C) Íleo biliar
D) Perforación intestinal
E) Hemoperitoneo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Perforación intestinal** (opción **D**). Perforación intestinal. La amigdalectomía es una intervención quirúrgica cuyas indicaciones están bien definidas y resultan fundamentales para el EUNACOM. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 125 4.01.1.027 · Litiasis biliar

Una paciente de 40 años, IMC: 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, desde hace 3 meses, que cede espontáneamente luego de algunos minutos. Se realiza una ecografía, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): El diagnóstico más probable es:

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colecistitis crónica
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis aguda

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Colelitiasis** (opción **A**). Tiene una imagen de cálculos con la sombra acústica clásica. Se debe programar cirugía electiva.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 161 4.01.1.056 · Secuelas de quemaduras

Un paciente de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua, de gran tamaño, en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención, refiere que, desde hace dos años, presenta una úlcera en relación a la cicatriz. Al examen físico se observa una úlcera de 2 cm en medio de la cicatriz. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tratamiento con nitrógeno líquido
B) Aseo quirúrgico
C) Resección amplia
D) Biopsia incisional
E) Curaciones con povidona y suero fisiológico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una úlcera de Majorlin, que es un tipo de carcinoma espinocelular de muy lento crecimiento, que aparece en cicatrices de grandes quemaduras. Su diagnóstico es la biopsia incisional o con una biopsia "punch" y luego de confirmar la histología, se procede a la excisión completa y manejo oncológico. En ocasiones, el carcinoma solo está en una zona del borde de la úlcera, por lo que se recomienda varias biopsias incisionales. Si no lo sabían, pues ahora ya lo saben y sea como sea, tenía "pinta" de cáncer, así que a biopsiarlo.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 25 4.01.4.008 · Radiografías contrastadas

Un paciente de 64 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, mayor en el flanco derecho y fosa ilíaca derecha, EVA 8/10 y que se ha asociado a malestar general. Al examen físico tiene FC: 87x', PA. 132/86 mmHg, T°: 37,2°C y examen abdominal que muestra abdomen doloroso a la palpación, mayor en la fosa ilíaca derecha, con signo de Blumberg positivo en la zona y ruidos hidroaéreos presentes, aunque disminuidos. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio en este paciente?

A) Colonoscopía
B) Enema baritado
C) Lapatomía exploradora
D) Ecografía abdominopélvica
E) Tomografía de abdomen y pelvis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Enema baritado). El hipotiroidismo se presenta con astenia, adinamia, intolerancia al frío, constipación, piel seca, bradipsiquia, caída de la cola de las cejas, bradicardia e hipotermia en casos severos, hiporreflexia y alteraciones de laboratorio como anemia macrocítica, hiponatremia con VEC normal, hiperbilirrubinemia indirecta, dislipidemia (hipercolesterolemia) y aumento de CK. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 77 4.01.2.026 · Quemaduras

Niño con quemadura en palmas y dedos, eritema importante y ampollas, inquieto e irritable en urgencias. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Aplicar apósitos de plata y hospitalizar
B) Enfriar con agua fría y cubrir con gasa estéril
C) Indicar analgesia endovenosa
D) Hospitalizar para manejo de quemaduras
E) Debridación bajo anestesia general inmediata

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Indicar analgesia endovenosa** (opción **C**). Indicar analgesia endovenosa. El antibiótico de elección en mordeduras es amoxicilina con ácido clavulánico; se indica en mordedura de gato, humana, extensa, en manos, o infectada. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 146 4.01.1.047 · Insuficiencia arterial cró

Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es el examen de elección?

A) Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa
B) AngioTAC de extremidades inferiores
C) Arteriografía de extremidades inferiores
D) Doppler venoso de extremidades inferiores
E) Índice tobillo-brazo (ITB)

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Índice tobillo-brazo (ITB)). Índice tobillo-brazo (ITB). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 179 4.01.4.009 · Mamografía

Paciente con lesión mamográfica BIRADS 3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Biopsia core guiada por imagen
B) Ecografía mamaria dirigida
C) RNM mamaria bilateral
D) Mamografía de control en 6 meses
E) Control en 1 año sin exámenes

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mamografía de control en 6 meses** (opción **D**). Mamografía de control en 6 meses. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 79 4.01.1.053 · Tumores benignos de partes

Joven con aumento de volumen blando no adherido en muslo derecho (?era en la espalda), estudio inicial:

A) Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)
B) Psoriasis
C) Dermatitis atópica
D) Dermatitis de contacto
E) Liquen plano

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 161 4.01.1.026 · Ictericia obstructiva

Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía:

A) Litiasis en vía biliar común
B) Lesión vía biliar iatrogénica
C) Ninguna de las anteriores es correcta
D) Todas las anteriores son correctas
E) No se dispone de información suficiente

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Lesión vía biliar iatrogénica). La evaluación preanestésica tiene como objetivo evaluar y minimizar los riesgos, evaluar la vía aérea y elegir el tipo de anestesia y fármacos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 160 **4.01.1.026 · Ictericia obstructiva**

Había un intestino irritable ?? - sii una señora con antecedente de SII, con cambio en patrón evacuatorio, sospechar neoplasia. Decia que tenia aumento de la severidad de los sintomas, y en explicito que no tenia baja de peso ni otros signos de alarma, yo puse una que decia hemograma y algo mas. Era Colono, es una bandera roja tener diarrea/cambio en deposiciones en AM →Colono → NO SE ENTIENDA LA REDACCION DE ESTA PREGUNTA Y NO RECUERDO ALGUIEN QUE LA MEJORE 161. Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía: a. litiasis en vía biliar comun b. lesión vía biliar iatrogenica

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Ninguna de las anteriores es correcta** (opción **A**). La evaluación preanestésica tiene como objetivo evaluar y minimizar los riesgos, evaluar la vía aérea y elegir el tipo de anestesia y fármacos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 11 **4.01.3.002 · Antimicrobianos. Conceptos**

Una paciente de 35 años consulta por dolor abdominal epigástrico recurrente, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra múltiples cálculos al interior de la vesícula biliar. Se decide realizar una colecistectomía laparoscópica electiva para su manejo. ¿Cuál de los siguientes esquemas antibióticos es de elección para ser administrado durante la cirugía como profilaxis de infección de la herida operatoria?

A) Amoxiclina más ácido clavulánico
B) Ceftriaxona
C) Clindamicina
D) Cloxacilina
E) Cefazolina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Profilaxis de la infección de la herida operatoria: La profilaxis con antibióticos durante la cirugía se realiza en heridas limpias contaminadas y contaminadas. Las heridas sucias o infectadas requieren tratamiento antibiótico, mientras que las heridas limpias no suelen necesitarlo (excepto en ciertas cirugías de alto riesgo: prótesis u órganos muy importantes). El esquema debe cubrir Staphylococcus y los microorganismos de la mucosa abierta en la heridas limpias contaminadas. La cefazolina es el fármaco de elección en la mayoría de los casos, incluyendo la colecistectomía electiva (cubre bien Gram+ y enterobacterias).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 21 **4.01.2.028 · Intoxicación por anestésic**

Una mujer de 28 años, trabajadora del área de la salud, es encontrada inconsciente por su pareja en el baño de su casa. Al examen físico, está comprometida de conciencia, tiene frecuencia cardíaca de 60 por minuto, frecuencia respiratoria de 8 por minuto y se observan pupilas mióticas, sin focalidad neurológica. ¿Qué tipo de fármaco es el responsable del cuadro de intoxicación de esta paciente?

A) Benzodiacepinas
B) Barbitúricos
C) Antidepresivos tricíclicos
D) Opioides
E) Hipoglicemiantes

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome Opioide: Este síndrome se caracteriza por compromiso de la conciencia, depresión respiratoria y miosis puntiforme (pupilas contraídas). Es importante diferenciarlo de otros síndromes: el síndrome por benzodiazepinas también presenta compromiso de conciencia y depresión respiratoria, pero sin alteración pupilar significativa; los síndromes adrenérgico y anticolinérgico causan midriasis (pupilas dilatadas); y el síndrome colinérgico, al igual que el opioide, se caracteriza por miosis (pupilas contraídas).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 61 **4.01.1.050 · Ulceras de las piernas (ve**

Un paciente de 58 años, con antecedente de várices en ambas piernas, de gran tamaño, consulta porque hace dos semanas sufrió un pequeño trauma en su extremidad inferior izquierda, evolucionando con una lesión ulcerada que ha aumentado de tamaño, hasta alcanzar 1,5 cm y que se ubica a 2 cm del maléolo interno. Al examen físico, se aprecia oscurecimiento de la piel circundante, más la presencia de las várices descritas. ¿Cuál es la etiología más probable de su lesión?

A) Infecciosa
B) Isquémica
C) Venosa
D) Neuropática
E) Por presión

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Úlcera venosa: Las úlceras venosas suelen ser poco dolorosas o incluso indoloras. Se ubican generalmente en el maléolo interno y se asocian al síndrome postflebítico, que se caracteriza por hiperpigmentación de la piel. En contraste, las úlceras arteriales son dolorosas y se ubican con mayor frecuencia en el maléolo externo, los ortejos o los talones. El fondo de las úlceras arteriales es isquémico, de color pálido o blanco, mientras que el fondo de las úlceras venosas es hiperémico y violáceo.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 27 **4.01.1.016 · Hemorroides - fisura anal**

Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hemorroidectomía de urgencia
B) Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local
C) Ligadura con banda elástica
D) Manejo médico conservador con analgesia y baños de asiento
E) Escleroterapia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hemorroides externas trombosadas en primeras 72h: trombectomía bajo anestesia local alivia el dolor en forma inmediata. Después de 72h, el manejo es conservador pues el trombo se reabsorbe.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 64 4.01.5.016 · Fibrobroncoscopía

Niño de 3 años con tos súbita, sibilancias unilaterales y disminución del murmullo vesicular en hemitórax derecho. Los padres refieren que estaba comiendo maní. Radiografía de tórax: hiperinsuflación derecha. ¿Cuál es el tratamiento definitivo?

A) Fibrobroncoscopía virtual (no es terapéutica)
B) Broncoscopía rígida con extracción del cuerpo extraño
C) Espirometría
D) TAC de tórax y observación
E) Antibióticos y kinesioterapia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Cuerpo extraño en vía aérea: tratamiento definitivo = broncoscopía rígida bajo anestesia general para extracción. La broncoscopía flexible puede ser diagnóstica pero la rígida permite la extracción segura. No diferir: riesgo de atelectasia y neumonía distal.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 151 4.01.2.011 · Colecistitis aguda

Mujer de 55 años con colecistitis aguda de 48 horas de evolución. Estable hemodinámicamente, fiebre 38°C, leucocitos 14.000. ¿Cuál es el manejo quirúrgico más adecuado?

A) Colecistectomía laparoscópica precoz (dentro de 72h)
B) Cirugía electiva en 6 semanas
C) Drenaje percutáneo y cirugía diferida
D) Solo ATB EV y observación
E) Colecistostomía abierta de urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Colecistitis aguda no complicada: colecistectomía laparoscópica precoz (<72h del diagnóstico) es superior al manejo diferido. Menor complicaciones, estadía hospitalaria y conversión a cirugía abierta.

TRAUMATOLOGÍA & ORTOPEDIA

Módulo 2: Cirugía y Especialidades · Colección Tomo 12

93 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

27 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.02.1.001	Artrosis primarias y secundarias	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.1.002	Displasia congénita de cadera	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 12 · C.6 (Pág. 16)
4.02.1.003	Escoliosis y deformidades vertebrales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.1.004	Infecciones osteoarticulares	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.1.005	Lumbago mecánico	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.1.006	Lumbociática radicular	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.1.007	Pie plano	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.1.008	Síndrome de hombro doloroso	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.1.009	Tumores óseos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	12 Q	Tomo 12 · 12.14 (Pág. 52)
4.02.2.001	Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.002	Disyunción-fractura del niño	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.003	Esguince grado1	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.004	Fractura de cadera	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 12 · 12.9 (Pág. 35)
4.02.2.005	Fractura de la muñeca	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.006	Fractura inestable de la pelvis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.007	Fracturas de diáfisis y metáfisis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.010	Lesiones de los nervios periféricos	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	9 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.011	Lesiones de partes blandas (contusiones,	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.012	Luxación del hombro	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.013	Luxofractura del tobillo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.02.2.014	Politraumatizado	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.2.015	Trauma raquimedular	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.3.002	Complicaciones de la inmovilización con yeso	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.3.004	Factores de riesgo de osteoporosis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.3.006	Prevención de displasia de cadera (diagnóstico precoz)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.4.003	Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)
4.02.4.005	Radiografía en tumores oseos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 12 · Traumatología (Pág. 8)

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 99 4.02.2.004 · Fractura de cadera

Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia estable. Destaca la extremidad inferior derecha en flexión y aducción, dolorosa, con imposibilidad de caminar. Se realiza radiografía anteroposterior de pelvis, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura de la cabeza femoral derecha
B) Fractura de zona posterior del cotilo derecho
C) Luxofractura posterior de cadera derecha
D) Fractura de pelvis inestable
E) Fractura extracapsular de cadera derecha

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Está en posición púdica, clásica de la luxación posterior de cadera; y la radiografía muestra la luxación posterior derecha. No queda claro el rasgo de fractura.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 50 4.02.2.004 · Fractura de cadera

Una paciente de 80 años sufrió una caída a nivel, luego de la cual no pudo levantarse, presentando mucho dolor. Al examen físico presenta acortamiento de la extremidad inferior derecha, con ligera abducción y rotación externa, sin equimosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esguince de cadera
B) Fractura de cadera
C) Luxación posterior de cadera
D) Fractura de pelvis
E) Fractura vertebral con lesión del plexo lumbar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fractura de cadera** (opción **B**). Es una fractura de cadera clásica, con la posición impúdica.. La fractura de cadera es una fractura osteoporótica frecuente en adultos mayores con una mortalidad a dos años cercana al cincuenta por ciento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 177 4.02.2.004 · Fractura de cadera

Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia estable. Destaca la extremidad inferior derecha en flexión y aducción, dolorosa. Se realiza radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura de cuello femoral derecho
B) Fractura posterior de cotilo derecho
C) Luxofractura posterior de cadera derecha
D) Fractura de pelvis inestable
E) Fractura extracapsular de cadera derecha

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La clínica en posición púdica (flexión y aducción) ya sugiere luxación posterior de cadera. La radiografía muestra la luxación posterior y un probable rasgo de fractura en el cuello.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 111 4.02.2.004 · Fractura de cadera

Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación: Fuente: www.radiopaedia.org El diagnóstico es:

A) Displasia del desarrollo de la cadera
B) Epifisiolisis
C) Fractura del cuello femoral
D) Osteomielitis del extremo proximal del fémur
E) Necrosis avascular de la cabeza femoral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Epifisiolisis** (opción **B**). Por clínica y por radiografía, tiene una epifisiolisis de la cabeza femoral izquierda.. La fractura de cadera es una fractura osteoporótica frecuente en adultos mayores con una mortalidad a dos años cercana al cincuenta por ciento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 98 4.02.2.004 · Fractura de cadera

Un hombre protagoniza un accidente de tránsito, chocando de manera frontal, contra otro automóvil. Presenta intenso dolor en la cadera derecha, que le impide caminar. En su examen tiene una rotación fija hacia interno, con aducción del muslo. El diagnóstico más probable es:

A) Fractura de cuello femoral
B) Fractura de cotilo
C) Esguince grado 3 de cadera
D) Luxación anterior de cadera
E) Luxación posterior de cadera

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Luxación posterior de cadera** (opción **E**). Es una luxación posterior clásica, con la posición impúdica.. La fractura de cadera es una fractura osteoporótica frecuente en adultos mayores con una mortalidad a dos años cercana al cincuenta por ciento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 10 4.02.2.004 · Fractura de cadera

Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en posición púdica. El diagnóstico más probable es:

A) Luxación anterior de cadera
B) Fractura intertrocantérica
C) Fractura de cuello femoral
D) Luxación posterior de cadera
E) Fractura de pelvis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La posición púdica es característica de la luxación posterior. La fractura, en cambio tiene posición impúdica (abducción, rotación externa y acortamiento).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 70 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Paciente de 35 años sufre traumatismo en la región posterior del húmero. Al examen: no puede extender la muñeca ni los dedos (caída de muñeca). ¿Qué nervio fue lesionado?

A) Nervio radial (en canal de torsión)
B) Nervio cubital
C) Nervio mediano
D) Nervio musculocutáneo
E) Nervio axilar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fractura de húmero + caída de muñeca (wrist drop) = lesión del nervio radial en el canal de torsión (surco espiral). Inerva extensores de muñeca y dedos (ECC, ECD, ELP).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 103 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Un paciente sufre una fractura de húmero derecho, que es manejada mediante reducción quirúrgica y osteosíntesis. Al quinto día, evoluciona con parestesias y dolor de la extremidad, asociada a imposibilidad de extender la muñeca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome compartimental
B) Compresión del nervio mediano
C) Lesión del nervio musculocutáneo
D) Atrapamiento del nervio cubital
E) Lesión del nervio radial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Lesión del nervio radial** (opción **E**). Es una clásica afectación del nervio radial, que está en estrecho contacto con la diáfisis humeral.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 112 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Un paciente de 43 años consulta por dolor y parestesias en el dedo meñique y anular derechos, que inició hace 3 años y ha progresado, aumentando su intensidad. Relata que, en la noche, los síntomas suelen ser más intensos y que actualmente tiene parestesias continuas en el meñique. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome del túnel carpiano
B) Contractura de Dupuytren
C) Radiculopatía C7
D) Atrapamiento cubital
E) Compresión del plexo braquial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Atrapamiento cubital** (opción **D**). Es un atrapamiento cubital clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 173 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Una paciente sufre una fractura de la diáfisis humeral derecha, la que es manejada mediante cirugía, con osteosíntesis con placa. A las 24 horas, evoluciona con dolor en el sitio de la fractura, asociada a inmposibilidad de extender la muñeca derecha. Mantie- ne la flexión activa de los dedos de esa mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombosis de la arteria braquial
B) Neurapraxia del nervio radial
C) Desplazamiento de la placa
D) Síndrome compartimental
E) Lesión del plexo braquial

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Confundía el hecho de haber dolor en la zona, lo que orientaba a un síndrome compartimental, pero solo se describía la afectación del nervio radial, sin otras altera- ciones, por lo que lo más probable es que haya sido la neurapraxia.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 41 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Una paciente de 35 años, sin antecedentes, sufre fractura de diáfisis humeral izquierda, evolucionando posteriormente con hipostesia del dorso de dicha mano, asociado a imposibilidad de realizar extensión de muñeca y falanges. ¿La estructura más probablemente dañada en este caso es?:

A) Nervio mediano
B) Nervio ulnar
C) Nervio radial
D) Nervio axilar
E) Nervio musculocutáneo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Nervio radial). De libro. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Nervio mediano, Nervio ulnar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 1 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Una mujer de 45 años consulta por debilidad para tomar objetos, desde hace 3 meses. Además presenta parestesias, especialmente en la noche, que mejoran al sacudir las manos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atrapamiento del nervio cubital
B) Polineuropatía
C) Síndrome de túnel carpiano
D) Lesión del nervio radial
E) Síndrome del opérculo torácico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome de túnel carpiano** (opción **C**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 102 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Una paciente de 56 años, diabética tipo 2, de larga data, consulta por dolor y parestesias en ambas manos, mayores en la noche, que se irradian hacia los codos. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de túnel carpiano
B) Síndrome del opérculo torácico
C) Neuropatía por atrapamiento del nervio cubital
D) Polineuropatía diabética
E) Síndrome de compresión radicular cervical

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy discutible, ya que tanto el túnel carpiano, como el tratamiento cubital son compatible con ese cuadro (incluyendo la irradiación a los codos) y la identificación de los dedos afectados es la única forma de diferenciarlos (1% a 42 dedos: nervio mediano; 40 y 59 dedos: cubital). Sin embargo, el antecedente de diabetes y la bilateralidad tan clara hace más probable un túnel carpiano.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 3 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Un paciente de 35 años consulta por debilidad del cuarto y quinto dedos derechos, es especial a la flexión, asociado a parestesias en dichos dedos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lesión de los tendones profundos
B) Síndrome del opérculo torácico
C) Atrapamiento del nervio radial
D) Síndrome de atrapamiento cubital
E) Síndrome de túnel carpiano

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome de atrapamiento cubital** (opción **D**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 175 4.02.2.010 · Lesiones de los nervios pe

Una paciente de 45 años, obesa y fumadora consulta por parestesias progresivas en la mano derecha, que la despiertan en la noche, por lo que debe sacudir las manos para que disminuyan y desaparecen cuando frota una mano contra la otra. Refiere, además, dificultades para las actividades en las que requiere fuerza de puño, como amasar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tumor de Pancoast
B) Síndrome del túnel carpiano
C) Enfermedad de Dupuytren
D) Hernia del núcleo pulposo cervical
E) Lesión del nervio radial

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome del túnel carpiano** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 9 4.02.1.009 · Tumores óseos

Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea herterogénea, ubicada en el extremo distal del fémur, con disrupción de la cortical y zonas líticas, con otras de aumento de la densidad. El diagnóstico más probable es:

A) Osteocondroma
B) Tumor de células gigantes
C) Osteosarcoma
D) Displasia ósea fibrosa
E) Quiste óseo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tumor óseo de aspecto maligno. Por ubicación y edad es osteosarcoma (adolescentes y adultos mayores). Recordar que Sarcoma de Ewing es diaisiario.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 39 4.02.1.009 · Tumores óseos

Una mujer de 18 años presenta traumatismo en la rodilla derecha, siendo diagnosticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evoluciona con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:

A) Osteomielitis del fémur distal
B) Osteosarcoma osteogénico
C) Fractura del fémur distal, con callo óseo
D) Osteocondroma
E) Hematoma calcificado

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta rara, ya que ni siquiera dicen que hay un tumor, pero reacción perióstica y el compromiso de partes blandas son clásicas de un tumor maligno. Por la edad, lo más probable es un osteosarcoma. Es frecuente en el Eunacom que se dé el antecedente de trauma (aunque no tenga relación) en distintos tipos de tumores, ya que ahí es que se lo palpan.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 53 4.02.1.009 · Tumores óseos

Una mujer de 17 años presenta traumatismo en la rodilla izquierda, siendo diagnos- ticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evolucio- na con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:

A) Osteomielitis del fémur distal
B) Osteosarcoma osteogénico
C) Fractura del fémur distal, con callo óseo
D) Osteocondroma
E) Hematoma en organización

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Osteosarcoma osteogénico** (opción **B**). Es un osteosarcoma clásico, aunque la pregunta estaba horriblemente redactada.. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 94 4.02.1.009 · Tumores óseos

Un paciente de 19 años, sin antecedentes, hace un mes sufre golpe contuso en rodilla izquierda mientras jugaba futbol, tras lo cual ha permanecido con dolor el cual ha aumentado en las últimas semana, asociado a aumento de volumen duro. Se solicita radiografía de rodilla que muestra lesión de gran tamaño en metáfisis y diáfisis de fémur, asociado a compromiso cortical. El diagnóstico más probable es:

A) Sarcoma de Ewing
B) Osteosarcoma
C) Osteoma osteoide
D) Sarcoma de partes blandas
E) Tumor de células gigantes

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por la edad es osteosarcoma. El de células gigantes es entre los 40 y 55 años. El sarcoma de Ewing es de localización diafisiaria, no metafisiaria.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 90 4.02.1.009 · Tumores óseos

Un adolescente de 17 años presenta un golpe en la rodilla izquierda, evolucionando con dolor en la cara anterior de la rodilla, que es manejado con analgésicos, sin embargo, no responde adecuadamente, por lo que se solicita una radiografía de rodilla y pierna, que muestra discontinuidad de la cortical de la diáfisis de la tibia, calcificación de partes blandas, reacción perióstica triangular de 2 cm y algunas zonas osteoblásticas con otras osteolíticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura en maduración
B) Hematoma calcificado
C) Osteomielitis aguda
D) Tumor óseo maligno
E) Condromalacia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Tumor óseo maligno** (opción **D**). Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 160 4.02.1.009 · Tumores óseos

Paciente con traumatismo de rodilla persistente; radiografía muestra reacción perióstica y aumento de densidad en tibia proximal. ¿Diagnóstico más probable?

A) Fractura de estrés tibial
B) Osteosarcoma
C) Osteomielitis crónica
D) Encondroma
E) Quiste óseo simple

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Osteosarcoma** (opción **B**). Osteosarcoma. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 154 4.02.1.009 · Tumores óseos

Un paciente de 15 años sufre una torsión de rodilla derecha, siendo diagnosticado de un esguince, por lo que se indica inmovilizador de rodilla. Sin embargo, no mejora luego de 10 días, sino que, por el contrario, el dolor ha ido en aumento y no responde bien a la analgesia con naproxeno y ketorolaco. Al examen físico, presenta dolor a los movimientos de flexoextensión de la rodilla y a la palpación en la zona proximal y medial de la tibia derecha, sin signo de bostezo al varo ni al valgo. Se solicita una radiografía de rodilla, que muestra aspecto heterogéneo de la tibia proximal, con reacción perióstica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Osteosarcoma
B) Fractura
C) Osteomielitis
D) Esguince severo de rodilla
E) Hematoma en organización

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Osteosarcoma** (opción **A**). Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 152 4.02.1.009 · Tumores óseos

Un niño de 13 años consulta por dolor y aumento de volumen, en relación a la pierna izquierda, que ha ido en aumento y lo hace cojear. Tiene antecedente de traumatismo en la zona. Se solicitan una radiografía y una resonancia magnética nuclear, que se muestran a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Osteocondroma
B) Osteosarcoma
C) Sarcoma de partes blandas
D) Tumor de células gigantes
E) Sarcoma de Ewing

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, pero que ya se había realizado antes y se trata de un sarcoma de Ewing clásico, especialmente por la edad (menores de 15 años es lo más frecuente, aunque incluso se ve en adultos jóvenes) y por localización diafisiaria. Eso sí, también podría ser un sarcoma de partes blandas (más frecuente desde los 15 años), pero la clara afectación ósea de la RMN y también de la Rx hace que la respuesta sea la E, sin dudarlo mucho.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 9 4.02.1.009 · Tumores óseos

Adolescente de 15 años con dolor en la rodilla derecha de 3 meses de evolución. Refiere haber tenido un golpe previo que no mejora. Radiografía: masa osteolítica con reacción perióstica en triángulo de Codman en la metáfisis distal del fémur. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura patológica
B) Osteomielitis crónica
C) Sarcoma de Ewing
D) Osteosarcoma
E) Condrosarcoma

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Osteosarcoma: masa osteolítica en METÁFISIS de huesos largos (fémur distal / tibia proximal) en adolescentes + triángulo de Codman (reacción perióstica) = osteosarcoma. El Sarcoma de Ewing ocurre en DIÁFISIS y produce patrón "cebolla". Ambos tratados con cirugía + quimioterapia.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 161 4.02.1.009 · Tumores óseos

Paciente con traumatismo de rodilla; radiografía muestra reacción perióstica, lisis cortical triangular y aumento de densidad en partes blandas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Metástasis ósea
B) Linfoma óseo primario
C) Condrosarcoma
D) Osteomielitis aguda
E) Tumor óseo maligno primario

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Tumor óseo maligno primario** (opción **E**). Tumor óseo maligno primario. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 163 4.02.1.009 · Tumores óseos

Un paciente de 17 años, sin antecedentes, presenta desde hace 1 mes dolor en muslo izquierdo asociado a impotencia funcional. Al examen físico se palpa aumento de volumen en cara interna de muslo, de consistencia aumentada, sin otros hallazgos. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Tomografía axial computada sin contraste
B) Ecotomografía
C) Tomografía axial computada con contraste
D) Radiografía
E) Resonancia magnética

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Resonancia magnética** (opción **E**). Sospechar un sarcoma, que se estudia con RMN. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 18 4.02.1.009 · Tumores óseos

Sd compresión medular en paciente con Ca de próstata y Mtt ósea. Estudio:

A) Rnm columna con gadolinio
B) Mielografía
C) Cintigrama óseo
D) Radiografía columna
E) TAC

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Rnm columna con gadolinio). Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 68 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Un hombre de 42 años presenta dolor en el hombro derecho, de dos semanas de evolución, que inició en relación a un partido de tenis y que limita sus actividades, en especial, los movimientos de abducción y elevación. Al examen físico tiene dolor a la palpación subacromial, con dolor a la abducción y elevación del hombro, que dificulta estos movimientos, por sobre 80°. Se solicitan radiografías de hombro, que muestran esclerosis del acromion y leve ascenso de la cabeza humeral. El diagnóstico más probable es:

A) Tendinitis cálcica
B) Pinzamiento subacromial
C) Rotura completa del tendón del supraespinoso
D) Capsulitis adhesiva
E) Tendinitis bicipital

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy rara, ya que parece un síndrome de manguito rotador. Sin embargo, el ascenso de la cabeza humeral orienta a la rotura del tendón supraespinoso. La tendinitis cálcica tendría calcificación del tendón del bíceps, lo que se vería. La capsulitis adhesiva limitaría totalmente los movimientos.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 127 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Hombre de 55 años con dolor en el hombro derecho al elevar el brazo entre 60-120° (arco doloroso). Prueba de Neer y Hawkins positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de pinzamiento subacromial (manguito rotador)
B) Luxación glenohumeral
C) Capsulitis adhesiva (hombro congelado)
D) Artritis reumatoide de hombro
E) Fractura de clavícula

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Arco doloroso 60-120° + Neer (+) + Hawkins (+) = síndrome de pinzamiento subacromial por tendinitis/desgarro del manguito rotador. Tratamiento: kinesioterapia + AINEs ± corticoides locales.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 82 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Una paciente de 43 años, secretaria, consulta porque, desde hace dos semanas, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha ido limitando sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación del brazo derecho, por sobre el hombro. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Capsulitis adhesiva de hombro
B) Tendinopatía del manguito rotador
C) Disyunción acromioclavicular
D) Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial
E) Hernia cervical con compresión radicular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una tendinopatía del manguito rotador clásica. La capsulitis adhesiva suele tener más dolor con clara limitación a los movimientos, por el dolor y, en la última fase, por fibrosis del hombro (por eso se le llama "hombro congelado"). La tendinitis de la cabeza larga del bíceps o simplemente "tendinitis bicipital" suele presentar dolor en la cara anterior del hombro, irradiado a la zona proximal del brazo y asociarse a dolor al comprimir la corredera bicipital (si se rompe el tendón, además, se presenta un chasquido, dolor súbito y equimosis de la zona).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 101 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Una paciente de 31 años, secretaria, consulta por dolor en el hombro derecho, que ha aumentado en el último tiempo. Ella refiere que es más intenso en la noche y que aparece especialmente al levantar el codo por sobre el hombro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tendinitis del manguito rotador
B) Hernia del núcleo pulposo cervical
C) Artrosis glenohumeral
D) Tendinitis de la cabeza larga del bíceps
E) Capsulitis adhesiva de hombro

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Tendinitis del manguito rotador** (opción **A**). Era una tendinitis del manguito rotador clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 126 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Una paciente de 45 años presenta dolor en el hombro derecho, que es mayor en la noche y que presenta impotencia funcional, que dificulta sus actividades. Al examen físico presenta dolor a la flexión y a la abducción tanto activa, como pasiva, del hombro derecho. La conducta más adecuada es:

A) AINES y reposo
B) AINES y kinesioterapia
C) Cabestrillo
D) Infiltración con corticoides
E) Cirugía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome del manguito rotador. Probablemente esta evolucionando a una capsulitis adhesiva (dolor al movimiento pasivo). Se debe dar analgésicos y movilizar precozmente, para evitar la anquilosis.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 141 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus ambas en tratamiento farmacológico, consulta por dolor en hombro derecho de varios meses de evolución, el cual aumenta de intensidad en la noche, asociado a impotencia funcional. Al examen físico sin dolor a la movilización pasiva y con dolor a la abducción y rotación externa de hombro derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Tendinopatía bicipital
B) Osteoartritis de hombro
C) Tendinopatía deltoídea
D) Tendinopatía del manguito rotador
E) Disyunción acromioclavicular leve

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El dolor mayor en la noche es característico. Además es la causa más frecuente de dolor en el hombro.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 119 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Una paciente de 58 años presenta dolor en el hombro derecho desde hace 4 meses, que aumenta con la actividad física. Refiere que es intenso, con EVA 6/10, empeorando en la noche. Al examen físico, la movilidad pasiva está conservada, pero presenta limitación en la movilidad activa, especialmente para elevar el brazo por encima del hombro y en los movimientos de rotación interna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Artrosis acromioclavicular
B) Artrosis glenohumeral
C) Síndrome del manguito rotador
D) Capsulitis adhesiva
E) Tendinopatía bicipital

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome de Manguito Rotador: El paciente presenta un síndrome de manguito rotador clásico. La capsulitis adhesiva, en cambio, se caracteriza por la limitación tanto de la movilidad pasiva como activa.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 140 4.02.1.008 · Síndrome de hombro doloros

Una paciente de 58 años, consulta porque, desde hace una semana, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha limitado sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación sobre 90° del brazo derecho. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Capsulitis adhesiva de hombro
B) Patología del manguito rotador
C) Artritis séptica
D) Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial
E) Artrosis de la articulación glenohumeral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Patología del manguito rotador** (opción **B**). Es un síndrome de manguito rotador clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 167 4.02.1.004 · Infecciones osteoarticular

Paciente de 67 años, con antecedente de pielonefritis tratada hace dos meses, presenta dolor lumbar desde hace un mes que se ha ido intensificando, asociándose a sensación febril durante los últimos días. Al examen físico presenta temperatura de 38ºC y dolor a la palpación de zona lumbar media. Se solicita radiografía lumbar que muestra aplastamiento de L2 y L3, asociados a imagen radiolúcida alrededor del disco intervertebral. El diagnóstico más probable es:

A) Osteosarcoma
B) Pielonefritis aguda
C) Osteoma osteoide
D) Espondilodiscitis
E) Espondilolistesis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por la PNA se hizo un absceso perirrenal, que se extendio al disco IV e hizo una espondilodiscitis. Es pregunta del MIR. La fiebre más lumbago mecánico es espondilodiscitis. La fiebre más lumbago inflamatorio, en cambio, es espondilitis anquilosante.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 126 4.02.1.004 · Infecciones osteoarticular

Hombre de 60 años con dolor, calor y aumento de volumen en la rodilla derecha de inicio súbito. Artrocentesis: líquido turbio, 50.000 GB con 90% PMN. Gram: cocos gram positivos en racimos. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Artritis séptica por Staphylococcus aureus
B) Gota aguda
C) Artritis reumatoide
D) Pseudogota (artritis por pirofosfato)
E) Artritis reactiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Artritis séptica: líquido articular >50.000 GB con PMN predominante + gram con cocos en racimos = Staphylococcus aureus. Requiere drenaje articular urgente + cloxacilina EV.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 47 4.02.1.004 · Infecciones osteoarticular

Tratamiento ATB de una osteomielitis de cadera en niño de 10 años:

A) Cefazolina Cefa pq no tenia factores de riesgo a sarm, como tto empírico (decía específicamente empírico la pregunta, lo mejor es partir asumiendo que es SAMR como es una infección grave con Vanco) b. Vancomicina
C) Ampicilina
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Cefazolina Cefa pq no tenia factores de riesgo a sarm, como tto empírico (decía específicamente empírico la pregunta, lo mejor es partir asumiendo que es SAMR como es una infección grave con Vanco) b. Vancomicina** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 52 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Un paciente de 63 años consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:

A) Coxartrosis
B) Fractura incompleta de cadera por estrés
C) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
D) Bursitis trocantérica
E) Síndrome de la fascia lata rígida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Bursitis trocantérica** (opción **D**). Parece una bursitis trocantérica clásica.. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 5 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Un paciente de 77 años presenta dolor inguinal derecho de 2 años de evolución, que aumenta con la marcha, limitándola. Al examen físico se aprecia pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Necrosis avascular de la cabeza femoral
B) Coxartrosis
C) Hernia foraminal S1
D) Pinzamiento femoroacetabular
E) Estenosis raquimedular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
por llevar dos años orienta a artrosis (coxartrosis = artrosis de cadera). Alguien anotó 2 semanas en FB: sería la necrosis avascular.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 14 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Pregunta 14 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 78 años consulta por dolor en ambas ingles, irradiado a los muslos, que inició hace 5 años y que es más intenso al caminar, lo que ha limitado su movilidad en el último tiempo. Se solicita una radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Displasia de caderas
B) Mestástasis óseas
C) Necrosis avascular de la cabeza femoral bilateral
D) Sacroileítis
E) Coxoartrosis bilateral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Coxoartrosis bilateral** (opción **E**). Es una artrosis de cadera, tanto por la clínica, como por la radiografía.. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 120 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Una paciente de 30 años, con antecedente de displasia de cadera derecha, tratada con cirugía abierta en su infancia, consulta por dolor muy intenso en la cadera izquier- da, que la hace cojear permanentemente. Al examen físico presenta acortamiento de 25

A) Tratamiento sintomático de la artrosis
B) Indicar tratamiento kenesioterapéutico
C) Realizar osteotomía acetabular
D) Instalar prótesis total de cadera
E) Compensar el acortamiento con calzado con realce

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En mi opinión tiene indicación de reemplazo articular. Pero la decisión exacta co- rresponde al especialista, según cada caso.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 1 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Un paciente de 57 años consulta por dolor lumbar progresivo de 5 meses de evolución. Su examen físico muestra algún grado de limitación a la flexoextensión lumbar, sin otras alteraciones. Se solicita una radiografía de columna lumbar, que muestra espondilosis moderada, con presencia de discopatía en el segmento L5-S1, con visualización de osteofitos en ambos cuerpos vertebrales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Espondilitis anquilosante
B) Espondilitis psoriática
C) Osteoporosis
D) Espondilodiscitis
E) Espondiloartrosis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Espondiloartrosis: La espondilosis a veces se usa como sinónimo de espondiloartrosis. Sin embargo, en otros contextos, se refiere a la disminución del grosor del disco intervertebral. Los osteofitos son propios de la artrosis.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 36 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Un paciente de 55 años consulta por dolor moderado en la rodilla derecha de 3 meses de evolución, que empeora con la ac8vidad Fsica, sin antecedente de trauma8smo. Su examen Fsico no muestra alteraciones y una radiograFa de rodilla derecha resulta normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar radiogra:as de cadera derecha
B) Solicitar resonancia magné2ca de rodilla derecha
C) Solicitar ecogra:a de rodillas
D) Realizar punción ar2cular
E) Solicitar niveles de ácido úrico y factor reumatoide

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Ante una gonalgia (dolor de rodilla), en la que no se encuentra una causa, lo primero es evaluar la cadera. Recordar la frase “la cadera llora por la rodilla”. Si bien el examen físico de cadera era lo primero, proceder a una radiografía de cadera, buscando artrosis, signos de pinzamiento, etc. parece la mejor opción. La RMN de rodilla también es una respuesta aceptable, pero, sin dudarlo la correcta es la A.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 139 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor de la rodilla izquierda, de 4 semanas de evolución, que le dificulta la marcha. Al examen físico, su rodilla no tiene alteraciones. ¿Qué otra articulación se debe examinar?

A) La cadera
B) La sínfisis del pubis
C) La sacroilíaca
D) El tobillo
E) La articulación astragalotarsiana

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (La cadera). Recordar que la patología de cadera puede producir gonalgia (dolor de rodilla).. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 4 4.02.1.001 · Artrosis primarias y secun

Un paciente presenta dolor en la cara lateral de la cadera derecha, que aumenta con la marcha y al recostarse apoyado en esa cadera. Los movimientos están conservados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndorme de la banda ileotibial
B) Bursitis ileopectínea
C) Bursitis trocantérica
D) Pinzamiento femoroacetabular
E) Artrosis de cadera

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Bursitis trocantérica** (opción **C**). Cuadro clásico. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 137 4.02.1.002 · Displasia congénita de cad

Un niño es diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante una radiografía, que muestra la displasia, con luxación del extremo proximal del fémur izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Doble pañal
B) Correas de Pavlik
C) Yeso con fijador
D) Osteotomía periacetabular tipo Ganz
E) Reducción abierta y fijación con osteosíntesis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Correas de Pavlik** (opción **B**). Tiene una displasia de cadera menor a 9 meses, que se trata con arnés de Pavlik.. Tratamiento siempre causal: resolver la obstrucción nasal o nasofaríngea De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 7 4.02.1.002 · Displasia congénita de cad

Un niño de 3 meses de edad se realiza una radiografía de pelvis, que muestra displasia de cadera izquierda, con índice acetabular de 36 grados. La indicación más adecuada es:

A) Ejercicios de rotación y compresión
B) Bota larga bilateral de yeso, con yugo
C) Yeso pelvipedio
D) Uso de doble pañal
E) Arnés de Pavlik

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Menores de 10 meses (según Minsal) o menores de 6 meses (universalmente aceptado) se manejan con correas de Pavlik

---

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 130 4.02.1.002 · Displasia congénita de cad

Niño de 9 años con cojera indolora progresiva de 3 semanas. Rx de cadera: aplanamiento y fragmentación de la cabeza femoral derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta?

A) Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes: derivar a ortopedia infantil
B) Sinovitis transitoria: reposo y AINEs
C) Artritis séptica: hospitalizar y cirugía
D) Displasia del desarrollo de cadera: arnés de Pavlik
E) Osteosarcoma: biopsia urgente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Necrosis avascular de la cabeza femoral en niño 4-10 años + Rx con fragmentación y aplanamiento = enfermedad de Perthes. Derivar a ortopedia para decidir tratamiento conservador vs quirúrgico según clasificación.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 52 4.02.2.001 · Complicaciones de los trau

Un paciente de 27 años sufre una fractura cerrada de antebrazo, que es manejada con un valva de yeso braquiopalmar. A las 5 horas presenta aumento del dolor y edema de la extremidad. El diagnóstico más probable es:

A) Trombosis venosa profunda
B) Síndrome compartimental
C) Distrofia simpático refleja
D) Alergia al yeso
E) Síndrome de túne carpiano agudo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por el corto tiempo de evolución y el dolor es síndrome compartimental. Además es clásico de las Fx de antebrazo. Falta información

---

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 131 4.02.2.001 · Complicaciones de los trau

Una paciente de 62 años sufre una caída a nivel, sufriendo una fractura del extremo distal del radio izquierdo, la que es manejada ortopédicamente, con un yeso braquiopalmar. A las 5 horas, evoluciona con intenso dolor, EVA 10/10, que no responde a la analgesia y se asocia a dificultades para mover los dedos. Al examen físico, se objetivan dedos con llene capilar enlentecido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de dolor locorregional complejo
B) Lesión de la arteria radial
C) Trombosis venosa profunda
D) Compresión del nervio mediano
E) Síndrome compartimental

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome compartimental** (opción **E**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 142 4.02.2.012 · Luxación del hombro

Un paciente de 27 años sufre una caída a nivel, con golpe del hombro, contra el piso. Evoluciona con intenso dolor e impotencia funcional, por lo que se solicitan radiografías de hombro, que. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reducción cruenta en una semana
B) Inmovilización por 10 días con yeso
C) Artroscopía para reparación del labrum
D) Inmovilización por 7 días con cabestrillo bloqueado
E) Reducción ortopédica de inmediato

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La luxación anterior de hombro se reduce ortopédicamente, de inmediato. Si recurre, se trata con cirugía.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 35 4.02.2.012 · Luxación del hombro

Un paciente de 23 años sufre una caída mientras jugaba fútbol, cayendo con el hombro derecho contra el piso y resultando en una luxación anterior de hombro derecho, la cual es confirmada con radiograFas de hombro, las cuales descartan la presencia de fracturas. ¿Qué evaluación debe realizarse obligatoriamente en el examen Fsico antes de proceder con las maniobras de reducción?

A) Buscar presencia de equimosis
B) Buscar deformación en “charretera”
C) Explorar la sensibilidad de la zona deltoidea
D) Evaluar la impotencia funcional
E) Evaluar crépito óseo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La luxación anterior se asocia a lesión del nervio axilar o circunflejo, que inerva al deltoides (abducción del hombro) y la sensibilidad en la zona deltoidea. Se debe consignar su alteración antes de la reducción, para que no se culpe luego al médico de haberla causado durante la reducción. Las demás opciones ya han sido evaluadas mediante la clínica (la luxación Gene hombro “en charretera”, impotencia funcional) y la radiografía.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 10 4.02.2.012 · Luxación del hombro

Un paciente de 24 años, sufre una caída a nivel, mientras jugaba básquetbol, cayendo con el hombro izquierdo, contra el suelo. Presenta impotencia funcional y al examen físico destaca dolor a la movilización del hombro izquierdo. Se solicita una radiografía AP de hombro y axial de escápula, que se muestran a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Luxación anterior de hombro
B) Fractura de escápula
C) Luxación acromioclavicular
D) Fractura de clavícula
E) Lesión del tendón del manguito rotador

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En la imagen se veía la disyunción acromioclavicular o luxación acromioclavicular, con leve desplazamiento hacia superior del extremo distal de la clavícula. La sola clínica, en este caso, no permite diferenciarlo. Sin embargo, es característico de la luxación anterior de hombro el signo de la charretera y, de la disyunción, el signo de la tecla de piano.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 48 4.02.2.012 · Luxación del hombro

Luxación anterior de hombro reducida + hipoestesia en cara lateral de brazo, nervio comprometido

A) Mediano
B) Cubital
C) Radial
D) Axilar
E) Musculocutáneo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Axilar). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Mediano, Cubital) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 51 4.02.2.006 · Fractura inestable de la p

Un paciente de 28 años sufre un accidente de tránsito de alta intensidad, por lo que es trasladado al servicio de urgencia. En la evaluación inicial tiene presión arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardíaca 115x' y se aprecia adolorido. Al examen, además, tiene dolor intenso al comprimir la zona iliaca y púbica y al realizar movimientos de rotación de la pelvis. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Instalar sonda Foley
B) Realizar laparotomía exploradora
C) Realizar radiografía AP de pelvis
D) Instalar sábana pélvica
E) Solicitar TAC de pelvis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una probable fractura de pelvis, pero por tener compromiso hemodinámico, lo más urgente es poner una vía venosa, administrar fluidos y estabilizar la pelvis (por ejemplo con una sábana pélvica).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 26 4.02.2.006 · Fractura inestable de la p

Un paciente de 30 años sufre una caída de altura, desde 15 metros, golpéandose contra el suelo. Al examen físico está orientado, con FC: 80x' y PA: 120/80 mmHg, con mucho dolor a la compresión de la pelvis, mayor a izquierda. Se solicita una radiografía de pelvis AP, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Pasar una sonda Foley
B) Indicar reposo en hamaca
C) Administrar antibióticos
D) Realizar cirugía
E) Solicitar ecografía de abdomen y pelvis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo primero frente a una fractura de pelvis, y frente a un politraumatizado en general, es hacer el ABC y en este caso, instalar vías venosas periféricas y aportar volumen. Luego, lo principal es reducir de manera externa la pelvis, de modo de evitar o al menos limitar las hemorragias pélvicas, lo que se puede hacer con un tutor externo y si no se tiene, son una férula neumática o por último con una sábana o hamaca pélvica (por eso elegimos esta respuesta, aunque la redacción no es la mejor). Una opción razonable era la cirugía de reducción, pero al preguntar la conducta inicial, parecería que la respuesta es otra. Respecto a la sonda Foley, es posible ponerla, pero la indicación es la retención urinaria y en la fractura de pelvis, hay riesgo de rotura uretral, lo que contraindica la Sonda Foley, hasta no haberla descartado con una uretrocistografía.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 34 4.02.2.006 · Fractura inestable de la p

Mujer con fractura de pelvis inestable con shock: conducta de reanimación inicial:

A) SF 0,9% yo puse esto u.u
B) Cerrar anillo pélvico (pienso que es esta porque es lo único que disminuirá el sangrado que le está matando) Pero preguntaban por manejo del shock inicial
C) Tratamientos específicos de la causa
D) Reparación arterial
E) Amoxicilina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **SF 0,9% yo puse esto u.u** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 141 4.02.2.005 · Fractura de la muñeca

Un paciente de 70 años, sufre una caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión, contra el suelo. Evoluciona con dolor en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Consulta al día siguiente, con la muñeca deformada en "dorso de tenedor" y presencia de equimosis en la zona palmar y en la zona dorsal. Presenta dolor a la compresión de la zona distal del radio. EL diagnóstico más probable es:

A) Esguince de muñeca
B) Fractura de la epífisis distal del radio
C) Disyunción del extremo distal del radio
D) Luxofractura de Monteggia
E) Fractura de escafoides carpiano

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fractura de la epífisis distal del radio** (opción **B**). Es una fractura de muñeca clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 65 4.02.2.005 · Fractura de la muñeca

Una paciente de 65 años sufre caída a nivel, apoyando la mano derecha contra el suelo, en extensión de la extremidad. Evoluciona con dolor intenso en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Al examen físico se aprecia deformidad de la muñeca y dolor epicrítico a la presión del radio distal. El diagnóstico más probable es:

A) Fractura de escafoides
B) Fractura de epifisis distal del radio
C) Disyunción-fractura de radio distal
D) Luxofractura de Monteggia
E) Luxación de cúpula radial

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una mala pregunta: no hay duda de que es una fractura de radio distal, pero la clínica es insuficiente para distinguir entre la fractura de epífisis y la disyunción fractura. Sin embargo, "disyunción fractura" o "luxofractura" se usa más para las fracturas de Monteggia y Galeazzi, que no corresponden a este cuadro, por lo que dejaremos la B como correcta. Sin embargo, la fractura no necesariamente es de la epífisis y puede ser de la metáfisis por ejemplo, así que definitivamente es una mala pregunta. Dolor epicrítico es sinónimo de dolor somático o superficial, en contraposición a dolor profundo o visceral.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 99 4.02.2.005 · Fractura de la muñeca

Un paciente de 28 años sufre una caída a nivel, cayendo sobre la mano izquierda, con extremidad superior izquierda en extensión. Al examen físico presenta dolor a la compresión axial del pulgar y al presionar la tabaquera anatómica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura de la base de la primera falange proximal
B) Fractura de escafoides
C) Fractura perilunar
D) Fractura del extremo distal del radio
E) Esguince de la primera articulación metacarpofalángica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Fractura de escafoides** (opción **B**). Es un fractura de escafoides clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 178 4.02.2.002 · Disyunción-fractura del ni

Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación: El diagnóstico es:

A) Displasia del desarrollo de la cadera
B) Epifisiolisis
C) Fractura del cuello del fémur
D) Luxacion de la Cadera izquierda
E) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una clásica epifisiolisis de la cabeza femoral (adolescente con claudicación de la marcha y dolor en la cadera. Se asocia a sobrepeso y obesidad). Además, se ve el signo del “helado caído”.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 100 4.02.2.007 · Fracturas de diáfisis y me

Un paciente sufre una caída a nivel, con golpe en el hombro derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se realizan radiografías de hombro, una de las que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía AP de hombro, con fractura del tercio medio de la clavícula derecha, con ligero desplazamiento, sin conminución) ¿Qué tipo de inmovilización es la más adecuada?

A) Vendaje axial de hombro
B) Vendaje en ocho
C) Yeso Velpeau
D) Yeso toracobraquial
E) Cabestrillo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

, ¿B?. El cabestrillo y el vendaje en 8 son los más usados en las fracturas del tercio medio de clavícula. Sin embargo, también se pueden usar otros tipos de inmovilización, según la valoración por el especialista. El vendaje en 8 se asocia a mayores molestias, por compresión cutánea y del complejo neurovascular axilar, así que el cabestrillo suele ser lo más recomendado. De todos, modos, es una pregunta de especialista.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 133 4.02.2.007 · Fracturas de diáfisis y me

Caída en paracaídas, se observa deformidad en valgo: a. Fractura platillo tibial lateral (esta, confirmado por un TMT)

B) Fractura cóndilo medial fémur
C) Rotura menisco anterior
D) Ligamento cruzado anterior
D) Laparotomía exploratoria
E) Cirugía laparoscópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Fractura cóndilo medial fémur, Rotura menisco anterior) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 179 4.02.2.007 · Fracturas de diáfisis y me

Un hombre sufre una caída, mientras corría, golpeándose el hombro contra el piso y presentando dolor e impotencia funcional de dicho hombro. Al examen físico tiene equimosis clavicular y dolor con todos los movimientos del hombro. Se solicita radiografía, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Yeso Velpeau
B) Yeso colgante
C) Vendaje en ocho
D) Cabestrillo
E) Osteosíntesis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discutible y la radiografía de este caso no es igual a la que apareció en el Eunacom. El tratamiento de la fractura de clavícula suele ser ortopédico y se basa actualmente en la inmovilización con un inmovilizador de hombro (un tipo de cabestrillo). Más antiguo, pero aún vigente es el vendaje en ocho. En el Eunacom real, la respuesta probablemente era el cabestrillo, a menos que se tratara de una pregunta muy antigua y repetida, que se haya quedado con el vendaje en 8. Sin embargo, en la imagen de la prueba que hicieron, hay un desplazamiento muy grande, mayor a 2 cm, por lo que se debe resolver con cirugía (en el Eunacom real probablemente la respuesta siempre será ortopédica y no se preguntará una excepción, como la de esta imagen, que insisto, era distinta a las del Eunacom real).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 159 4.02.2.011 · Lesiones de partes blandas

Paciente obeso con dolor en la cara externa de la cadera, claudicación y dolor a la palpación lateral con limitación a la rotación interna. ¿Diagnóstico más probable?

A) Coxartrosis (artrosis de cadera)
B) Síndrome de la banda iliotibial
C) Tendinopatía del glúteo medio
D) Bursitis trocantérica
E) Fractura de estrés del cuello femoral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Bursitis trocantérica** (opción **D**). Bursitis trocantérica. Las lesiones de partes blandas incluyen contusiones, desgarros musculares, hematomas, esguinces, quiste de Baker y rotura del tendón de Aquiles. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 141 4.02.2.011 · Lesiones de partes blandas

Una paciente de 65 años, con IMC: 34, consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, el dolor le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:

A) Coxartrosis
B) Fractura incompleta de cadera por estrés
C) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
D) Bursitis trocantérica
E) Síndrome de la fascia lata rígida

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Bursitis trocantérica** (opción **D**). Las lesiones de partes blandas incluyen contusiones, desgarros musculares, hematomas, esguinces, quiste de Baker y rotura del tendón de Aquiles. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 162 4.02.2.011 · Lesiones de partes blandas

Futbolista de 22 años que sufre giro brusco con la rodilla semiflexionada. Presenta edema articular rápido (hemartros), signo del cajón anterior positivo y prueba de Lachman positiva. ¿Qué estructura se lesionó?

A) Ligamento cruzado anterior (LCA)
B) Ligamento cruzado posterior (LCP)
C) Ligamento colateral medial (LCM)
D) Menisco medial
E) Ligamento patelofemoral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cajón anterior (+) + Lachman (+) + hemartros post trauma en valgus/rotación = ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA). Es la lesión ligamentaria más frecuente en deportistas jóvenes.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 8 4.02.2.011 · Lesiones de partes blandas

Un paciente de 65 años sufre una caída a nivel, con golpe en la rodilla derecha. Evoluciona con dolor e impotencia funcional. Se observa depresión suprarrotuliana en dicha rodilla y se solicita una radiografía de rodilla derecha, que no evidencia rasgos de fractura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Luxación de rótula
B) Disfunción patelo-femoral
C) Rotura del ligamento cruzado anterior
D) Rotura del ligamento rotuliano
E) Rotura del ligamento del cuádriceps

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Solo por la anatomía es posible adivinar la respuesta. El ligamento del cuádriceps está sobre la rótula. El tendón rotuliano está debajo de la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 95 4.02.1.005 · Lumbago mecánico

Hombre de 45 años con lumbalgia mecánica de 5 días de evolución, sin irradiación, sin signos de alarma. EF: dolor a la palpación paravertebral lumbar, sin déficit neurológico. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Analgesia (AINEs o paracetamol) + kinesioterapia activa; no reposo en cama
B) Reposo absoluto por 7 días
C) Cirugía de columna
D) Infiltración epidural de corticoides
E) Resonancia magnética urgente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lumbalgia mecánica aguda sin alarma: AINEs por corto plazo + actividad física progresiva + kinesioterapia. El reposo en cama prolonga la incapacidad. Sin indicación de imagen en fase aguda.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 29 4.02.1.005 · Lumbago mecánico

Un paciente de 40 años, oficinista, estuvo moviendo muebles durante 2 días, evolucionando luego con intenso dolor lumbar, que le impide realizar sus actividades. Al examen físico se aprecia muy adolorido, con dificultades para subirse a la camilla y para caminar, tiene IMC de 28 y se observa una contractura muscular a nivel lumbar, con dolor ante todos los movimientos de la columna lumbar, sin signos de irritación nerviosa. Además de administrar analgésicos, la indicación más adecuada es:

A) Resonancia magnética nuclear
B) Radiografía de columna lumbosacra
C) Kinesioterapia motora por 10 días
D) Reposo en cama por 5 días
E) Reposo laboral por 3 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un lumbago mecánico común y corriente (suelen ser muy intensos). Es fundamental la analgesia, el reposo relativo (no en cama) y, una vez que el dolor ha cedido, indicar KNT por largo tiempo, de modo de fortalecer los músculos del core (abdominales, lumbares, multífidos y glúteos), para disminuir las recurrencias.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 34 4.02.3.006 · Prevención de displasia de

Niño de 3 meses con radiografía de pelvis con ángulos acetabulares bajo 30° bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar arnés de Pavlik de inmediato
B) Mantener controles habituales
C) Derivar a traumatología pediátrica urgente
D) Solicitar ecografía de caderas
E) Iniciar tracción cutánea

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener controles habituales** (opción **B**). Mantener controles habituales. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 40 4.02.3.006 · Prevención de displasia de

Un niño de 3 meses de edad se realiza radiografía anteroposterior de pelvis, como screening para displasia de cadera. El ángulo acetabular se informa como 26° a derecha y 28° a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a traumatología infantil
B) Indicar doble pañal
C) Indicar arnés de Pavlik
D) Realizar ecografía de cadera
E) Mantener los controles habituales de niño sano

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El ángulo acetabular normal es de 30% o menos hasta los 3 meses. Sobre esa edad el ángulo normal se va achicando, por lo que,

---

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 140 4.02.3.006 · Prevención de displasia de

Un niño de 3 meses de edad acude a control de niño sano, con una radiografía anteroposterior de pelvis, que muestra ángulo acetabular de 28° a derecha y 26° a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Correas de Pavlik
B) Derivar a traumatología
C) Usar doble pañal
D) Mantener el control habitual
E) Solicitar ecografía de caderas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Derivar a traumatología** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 122 4.02.1.003 · Escoliosis y deformidades

Una paciente de 63 años presenta dolor dorsal intenso, que inició hace 5 días, en relación a un esfuerzo en flexión y que ha aumentado, limitando significativamente sus actividades de la vida diaria. Tiene antecedente de una fractura de muñeca hace un año, que requirió tratamiento quirúrgico. Al examen físico se aprecia adolorida, con signos vitales normales, dolor a la movilización activa y pasiva de su columna dorsal, que limita los movimientos de flexo-extensión. A la inspección la curvatura dorsal se observa redonda, sin cifosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hernia del núcleo pulposo
B) Tuberculosis vertebral
C) Espondilolistesis dorsal
D) Espondilosis dorsal
E) Fractura vertebral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una clásica fractura vertebral por aplastamiento del cuerpo vertebral, causada por osteoporosis, que también fue la causa de su fractura de muñeca.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 159 4.02.1.007 · Pie plano

Niño de 8 años con pie plano flexible asintomático. Arco plantar presente al pararse en puntillas. Sin dolor, sin limitación funcional. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tranquilizar a los padres: pie plano flexible fisiológico, no requiere plantillas ni tratamiento
B) Plantillas correctoras
C) Derivar a ortopedia
D) Fisioterapia intensiva
E) Cirugía correctora

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pie plano flexible en niño (<10 años) con arco que reaparece al puntillas = fisiológico. No hay evidencia de que las plantillas modifiquen el desarrollo del arco. Solo se trata si es doloroso o rígido.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 170 4.02.1.007 · Pie plano

Paciente que comenzó a trotar, presenta dolor en el pie y callosidades; arco plantar pronunciado e hiperqueratosis anterior. ¿A qué corresponde esta alteración?

A) Pie plano
B) Pie cavo
C) Pie equino
D) Pie varo
E) Hallux valgus

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Pie cavo). Pie cavo. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Pie plano, Pie equino) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 89 4.02.1.007 · Pie plano

Un paciente de 30 años empieza a trotar hace 2 semanas, sin embargo, refiere que deforma las zapatillas y que presenta dolor en la planta del pie y el antepié. Al examen físico se aprecia arco plantar muy marcado y callosidades en la zona anterior del pie, a nivel de la cabeza de los huesos metatarsianos. ¿Cómo se conoce esta formación del pie?

A) Pie plano
B) Pie varo
C) Pie bot
D) Pie equino
E) Pie cavo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Pie cavo). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Pie plano, Pie varo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 76 4.02.1.007 · Pie plano

Recién nacido con pie equino varo bilateral (CTEV) detectado al nacimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control en el próximo control de salud infantil
B) Derivar a ortopedia infantil para inicio de método Ponseti
C) Hospitalizar para cirugía inmediata
D) Observación domiciliaria: se corrige solo
E) Kinesiología ambulatoria y férulas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pie equino varo congénito: derivación URGENTE a ortopedia pediátrica para inicio del método de Ponseti (yesos seriados + tenotomía percutánea del Aquiles si necesario). Debe comenzarse en las primeras semanas de vida para mejores resultados. Es corregible con tratamiento precoz.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 162 4.02.4.005 · Radiografía en tumores ose

Paciente con aumento de volumen en muslo derecho; ecografía visualiza lesión sólida en relación al recto anterior. ¿Cuál es el examen a solicitar?

A) Biopsia incisional inmediata
B) TAC de muslo con contraste
C) RNM de muslo
D) PET-CT corporal total
E) Arteriografía de extremidad inferior

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (RNM de muslo). RNM de muslo. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 138 4.02.4.005 · Radiografía en tumores ose

Una paciente de 72 años presenta aumento de volumen, en relación a la cara interna del muslo derecho, que aumentado de tamaño en los últimos meses. Al examen físico, se aprecia una tumoración de 10 cm de diámetro, de consistencia similar al músculo. Se realiza ecografía, que muestra un tumor sólido de 12 cm, en relación al músculo recto femoral derecho. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir con el estudio de este paciente?

A) Radiografía de fémur
B) PET scan
C) Hemograma y biopsia de médula ósea
D) Tomografía axial computada de muslo
E) Resonancia magnética nuclear de muslo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Resonancia magnética nuclear de muslo). Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 57 4.02.3.002 · Complicaciones de la inmov

Mujer de 40 años con fractura de muñeca que fue enyesada. 3 horas después refiere dolor intenso progresivo en el antebrazo que no cede con analgesia, parestesias y sensación de tensión bajo el yeso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome compartimental agudo
B) Trombosis venosa profunda
C) Reacción alérgica al yeso
D) Fractura secundaria
E) Distrofia simpática refleja

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Dolor desproporcionado + parestesias + tensión bajo yeso en extremidad inmovilizada = síndrome compartimental agudo. Emergencia: retirar yeso inmediatamente y fasciotomía si no mejora.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 158 4.02.3.002 · Complicaciones de la inmov

Paciente con fractura de muñeca enyesada; 5 horas después presenta dolor intenso, hipoestesia y llene capilar enlentecido. ¿Diagnóstico más probable?

A) Síndrome compartimental agudo
B) Trombosis venosa profunda del miembro superior
C) Lesión arterial por el yeso
D) Compresión del nervio radial
E) Reacción alérgica al yeso

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome compartimental agudo** (opción **A**). Síndrome compartimental agudo. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 4 4.02.3.002 · Complicaciones de la inmov

Un paciente de 20 años hace 12 horas sufre una fractura cerrada de pierna derecha, mientras jugaba fútbol, presentando dolor e impotencia funcional. Se administran analgésicos y su fractura es inmovilizada con una bota larga de yeso. Sin embargo, evoluciona con intenso dolor de la pierna, más edema del pie ipsilateral. La conducta inicial más adecuada es:

A) Solicitar nuevas radiografías
B) Administrar diuréticos
C) Elevar la extremidad
D) Solicitar TAC de pierna
E) Retirar inmediatamente el yeso

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome compartimental: La sospecha clínica es de síndrome compartimental. La conducta adecuada es: 1) Retirar el yeso de inmediato. 2) Evaluación urgente por un traumatólogo para realizar una fasciotomía amplia. El diagnóstico es clínico, aunque se puede medir la presión intracompartimental con un tonómetro, si está disponible.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 57 4.02.2.003 · Esguince grado1

Dolor de rodilla jugando fútbol por movimiento de torsión, al examen físico con dolor al valgo, sin bostezo:

A) Rotura ligamento cruzado posterior
B) Ligamento cruzado anterior
C) Esguince colateral medial (pero no tenía bostezo)
D) Rotura menisco medial (tenía sentido con el mecanismo de lesión en torsión)
E) Hemograma y VHS

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Esguince colateral medial (pero no tenía bostezo)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 139 4.02.1.006 · Lumbociática radicular

Un paciente de 60 años consulta por lumbago intenso de 2 semanas de evolución, asociado a disfunción eréc8l, que no ha respondido al tratamiento con analgésicos orales. Al examen Fsico, presenta limitación a los movimientos de flexoextensión y flexión lateral de la columna lumbar, debido al dolor. Además, se obje8va anestesia de la zona perineal. El diagnós8co más probable corresponde a un síndrome:

A) Lumbociá2ca
B) Facetario lumbar
C) Compresión medular
D) Sacroilíaco
E) De cauda equina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto la compresión del cono medular como de la cauda equina se presentan con anestesia en silla de montar y disfunción sexual. De las opciones, la más razonable es el síndrome de cauda equina, ya que el síndrome de compresión medular clásico Gene compromiso motor y sensitivo, sin tanta afectación pudenda, con excepción del cono medular, que ya se explicó.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 130 4.02.1.006 · Lumbociática radicular

Paciente con antecedente de dolor en espalda, irradiado a glúteos, contractura paravertebral. dolor a la palpación de la columna lumbar y claudicación de la marcha y al estar mucho tiempo de pie, Lasegue negativo, rx de columna lumbar con pinzamiento discal y artrosis lumbar de L3-L4-L5 cuál era:

A) Claudicación neural intermitente
B) Fractura por compresión
C) Pelviespondilopatía
D) Hernia lumbar
E) Sacroileítis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Claudicación neural intermitente). La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 7 4.02.4.003 · Radiografía huesos largos

Una paciente de 68 años hace dos días sufre torsión del tobillo derecho, mientras bajaba escaleras. Evoluciona con intenso dolor, que le dificulta caminar. Al examen físico presenta edema de tobillo derecho, con equimosis bimaleolar, asociado a dolor a la palpación fibular ipsilateral. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar inmovilizador de tobillo
B) Inmovilizar con bota larga de yeso
C) Solicitar radiografías de tobillo
D) Solicitar TAC de tobillo
E) Indicar reposo y analgesia, con elevación de la extremidad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Sospecha de fractura de tobillo: La soepecha es una fractura de tobillo, principalmente por el dolor a la palpación ósea. Sin embargo, tanto en un esguince como en una sospecha de fractura, la conducta inicial es descartar la fractura con radiografías de tobillo (AP, lateral y oblicua).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 165 4.02.4.003 · Radiografía huesos largos

paciente adulta mayor con signos de fractura de pie, aumento de volumen, limitación funcional y con mucho dolor al apoyar pie, decía cual era estudio dx de elección

A) Ecografía
B) Resonancia magnética
C) Cintigrafía
D) TAC
E) RX

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (TAC). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecografía, Resonancia magnética) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 39 4.02.2.015 · Trauma raquimedular

Una paciente de 67 años consulta por dolor de espalda, que inició de manera súbita, en relación a actividades en las que levantaba peso en flexión. El dolor es intenso, por lo que limita sus actividades de la vida diaria. Al examen físico, se observa dolor a los movimientos de flexoextensión de la columna y se observa tórax encorvado, pero sin cifosis. Su examen neurológico es normal y presenta dolor a la palpación vertebral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lumbago mecánico
B) Lumbociática mecánica
C) Fractura de cuerpo vertebral
D) Espondiloartrosis lumbar
E) Espondilitis anquilosante

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fractura Vertebral: Aunque inicialmente parece un lumbago mecánico, la edad, la curvatura torácica y el dolor a la palpación vertebral sugieren una fractura vertebral como diagnóstico más probable.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 40 4.02.3.004 · Factores de riesgo de oste

Una paciente de 67 años consulta por dolor de espalda, que inició de manera súbita, en relación a actividades en las que levantaba peso en flexión. El dolor es intenso, por lo que limita sus actividades de la vida diaria. Al examen físico, se observa dolor a los movimientos de flexoextensión de la columna y se observa tórax encorvado, pero sin cifosis. Su examen neurológico es normal y presenta dolor a la palpación vertebral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lumbago mecánico
B) Lumbociática mecánica
C) Fractura de cuerpo vertebral
D) Espondiloartrosis lumbar
E) Espondilitis anquilosante

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fractura Vertebral: Aunque inicialmente parece un lumbago mecánico, la edad, la curvatura torácica y el dolor a la palpación vertebral sugieren una fractura vertebral como diagnóstico más probable.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 134 4.02.2.014 · Politraumatizado

Un niño de 8 años sufre un atropello mientras cruzaba la calle, resultando con golpe en la espalda y las extremidades. Ingresa con marcada disnea, saturando 85% a aire ambiental. Sus signos vitales muestran taquicardia a 150 la8dos por minuto y presión arterial 70/40 mmHg. Además, se observan múl8ples equimosis y, en el examen pulmonar se ausculta asimetría del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar izquierdo. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?

A) Realizar intubación orotraqueal
B) Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación
C) Puncionar el espacio pleural izquierdo
D) Solicitar radiogra:a de tórax
E) Solicitar TAC de tórax

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha clínica es un neumotórax a tensión, cuyo manejo es prioritario en el ABC. Se debe descomprimir de inmediato, mediante punción o toracostomía de urgencia. Si se punciona, se suele hacer en la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal, o en la línea axilar media en el quinto espacio intercostal.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 138 4.02.2.013 · Luxofractura del tobillo

Un paciente de 21 años sufre accidente en esquí con caída y torsión del tobillo derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se solicita radiograFa de tobillo que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Reposo con extremidad en elevación
B) Reducción cerrada e inmovilización con valva de yeso
C) Analgésicos y apoyo progresivo con mínima carga
D) Vendaje compresivo
E) Tracción e inmovilización con yeso de la extremidad

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una luxofractura de tobillo, cuyo manejo es quirúrgico. Sin embargo, el manejo inicial consiste en analgesia, reducción cerrada (bajo anestesia o sedación) e inmovilización transitoria, con valva de yeso abierta, para evitar un síndrome compartimental. Este mismo manejo aplica a otras fracturas desplazadas, mientras se espera la cirugía. Fuente imagen: Radiopaedia.

UROLOGÍA

Módulo 2: Cirugía y Especialidades · Colección Tomo 13

84 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

29 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.03.1.002	Cáncer de próstata	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.003	Cáncer de vejiga y urotelio	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.005	Disfunción sexual de causa orgánica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.007	Epididimitis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.008	Estenosis uretral	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.009	Fimosis, parafimosis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.012	Hidronefrosis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.013	Hiperplasia prostática benigna	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.014	Incontinencia urinaria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.015	Infección urinaria alta y baja	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.017	Infertilidad masculina	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.019	Malformaciones congénitas nefrourológicas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.020	Quistes del epidídimo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.022	Tumor renal	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 13 · 13.11 (Pág. 41)
4.03.1.024	Tumor testicular	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.025	Urolitiasis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.1.028	Varicocele	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.001	Cólico renal	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	7 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.004	Priapismo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.005	Prostatis aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.006	Retención urinaria aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.007	Torsión testicular	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	6 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.008	Trauma urológico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.2.009	Traumatismo uretral	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.4.003	Pielo TAC	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.4.004	TAC de abdomen y pelvis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.4.005	Uretrocistografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
4.03.5.001	Biopsia prostática	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)
4.03.5.002	Cistoscopia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 13 · Urología (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 104 4.03.1.013 · Hiperplasia prostática ben

Un paciente de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril y diabetes mellitus en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta desde hace 3 meses y en forma progresiva, poliaquiuria y nicturia, asociado a latencia, chorro miccional doble y débil. Al examen físico se palpa próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Se solicita antígeno prostático que resulta en 3,5ng/ml. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar prostatectomía vía resección transuretral
B) Realizar prostatectomía por vía retropúbica
C) Indicar alfa agonista
D) Indicar inhibidor de la 5 alfa reductasa
E) Indicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Primero se deben indicar alfa-ANTAgonistas, porque no hay ninguna indicación estricta de cirugía. Pero de las opciones que aparecen la RTU es la única aceptable (aunque no se dice el tamaño de la próstata, porque si es mayor a 60cc, se debe hacer cirugía abierta y no RTU). Los inhibidores de la 5 alfa reductasa no sirven. La biopsia solo está indicada si TR positivo o APE mayor a 4 o velocidad de APE mayor a 0,75.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 8 4.03.1.013 · Hiperplasia prostática ben

Un paciente de 50 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por poliaquiuria, nicturia, latencia y debilidad del chorro miccional desde hace meses, no asociado a otros síntomas. Su tacto rectal muestra próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Con respecto a este caso, ¿Cuál de las siguientes es una indicación absoluta para resolución quirúrgica en esta patología?

A) Hematuria en una ocasión
B) Retención aguda de orina
C) Residuo postmiccional de 150 ml
D) Prostata mayor a 40 cc
E) Antígeno prostático de 5 ng/ml

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una HPB. La Retención urinaria aguda es indicación absoluta de Qx. Hematuria e una ocasión y residuo de 150 ml son indicaciones relativas (sobre 150 ml se opera). El APE elevado solo es indicación de Bx. Es una mala pregunta y muy discutible, pero sin duda la respuesta es B.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 80 4.03.1.013 · Hiperplasia prostática ben

Un paciente de 70 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, consulta por escapes de grandes cantidades de orina, asociada a deseos intensos de ir al baño. Se solicita una ecografía vesicoprostática que visualiza adenoma prostático de 50 cc de volumen, vejiga urinaria con paredes engrosadas y residuo postmiccional significativo ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Imipramina oral
B) Tamsulosina oral
C) Amitriptilina oral
D) Tolterodina oral
E) Cloruro de trospio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

HPB con complicaciones + incontinencia de urgencia. El alfa-bloqueante (tamsulosina) es el tratamiento de primera línea para la HPB con síntomas obstructivos y residuo postmiccional. (Nota: la pauta original no recuerda bien esta pregunta, pero apunta a tamsulosina.)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 50 4.03.4.004 · TAC de abdomen y pelvis

Paciente de 30 años, sufre caída de altura resultando con traumatismo contuso en flanco derecho, asociado a hematuria macroscópica. Al examen físico presenta equimosis en flanco derecho, sin otros hallazgos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es el más indicado para el estudio de este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) Tomografía axial computada sin contraste de abdomen
C) Radiografía abdominal
D) Tomografía axial computada con contraste de abdomen
E) Pielografía de eliminación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un traumatismo renal. Se estudia con el Uro-TAC, que tiene contraste IV. El pielo-TAC que viene sin contraste es para la litiasis.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 33 4.03.2.001 · Cólico renal

Un paciente de 32 años presenta un cuadro de cólico renal, asociado a microhematuria en el sedimento de orina. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio de este paciente?

A) UroTAC
B) PieloTAC
C) Pielografía de eliminación intravenosa
D) Ecografía
E) Radiografía simple

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El cólico renal se estudia con PieloTAC (TAC sin contraste). El UroTAC se utiliza como estudio de la hematuria, después de descartar TU, cuando se sospecha cáncer, ya que dibuja bien la vía urinaria.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 158 4.03.2.001 · Cólico renal

Paciente con hidronefrosis izquierda severa por urolitiasis y antecedente de nefrectomía derecha previa (monorreno). Sin infección activa. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Catéter doble J para aliviar la obstrucción y preservar la función renal
B) Nefrectomía izquierda
C) Nefrostomía percutánea de urgencia
D) Litotricia extracorpórea sin derivación
E) Solo analgesia y observar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Monorreno con obstrucción ureteral por cálculo: urgencia urológica. Catéter doble J (endoprótesis ureteral) descomprime el sistema colector y preserva la función del único riñón funcionante.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 20 4.03.2.001 · Cólico renal

¿Cuál es el examen de elección para el enfrentamiento inicial de un paciente de 22 años, en su primer cuadro de cólico renal, con microhematuria?

A) Pielografía de eliminación
B) UroTAC
C) PieloTAC
D) Ecografía renal y vesical
E) Radiografía simple

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El diagnóstico de cólico renal es clínico. El pieloTAC es el examen de elección para identificar la ubicación y tamaño del cálculo renal, de modo de determinar si se observa (menor a 1 cm) o si se saca mediante LEC u otra intervención. El UroTAC, en cambio, se usa para estudiar el trauma renal y la hematuria, en que se sospecha cáncer, antes de la cistoscopía.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 56 4.03.2.001 · Cólico renal

Un paciente de 27 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 2 horas de evolución tipo cólico, irradiado a genitales, náuseas y vómitos, sudoración y hematuria. Al examen físico se encuentra inquieto, con puño percusión positiva a izquierda. El fármaco de elección para el manejo de este paciente es:

A) Ketorolaco
B) Acetaminofeno
C) Pargeverina
D) Tramadol
E) Clonixinato de lisina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ketorolaco** (opción **A**). Tiene un cólico renal.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 27 4.03.2.001 · Cólico renal

Un paciente de 22 años presenta un cuadro de dolor a la fosa lumbar derecha, irradiado al flanco derecho intenso ipsilateral y asociado a vómitos, que ha manejado con analgésicos. Evoluciona dos días después con malestar general y fiebre de 38,8°C. Su sedimento de orina muestra Se solicita pieloTAC, que muestra presencia de un cálculo de 9 mm, en el tercio distal del uréter derecho, con presencia de hidroureteronefrosis ipsilateral. Además de iniciar analgésicos y antibióticos, ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Realizar nefrolitotomía abierta
B) Realizar nefrolitotomía percutánea
C) Realizar litotripsia extracorpórea
D) Instalar un catéter doble J
E) Indicar tratamiento médico expulsor

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Instalar un catéter doble J** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 100 4.03.2.001 · Cólico renal

Paciente con cálculo de 4 mm en uréter, hidroureteronefrosis, orina inflamatoria y fiebre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Litotripsia extracorpórea de urgencia
B) Instalar catéter doble jota
C) Manejo ambulatorio con hidratación y analgesia
D) Antibiótico oral y control en 48 horas
E) Nefrolitotomía percutánea

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Instalar catéter doble jota** (opción **B**). Instalar catéter doble jota. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 100 4.03.2.001 · Cólico renal

Un paciente de 26 años presenta un cuadro de dolor lumbar, asociado a inquietud motora de 5 día de evolución. Hace 2 días se agrega fiebre y compromiso del estado general, más vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia FC: 105x', PA: 100/70 mmHg, T°: 38°C, puño percusión positiva a izquierda. Se solicita pieloTAC que muestra imagen cálcica en el tercio medio del uréter izquierdo, con dilatación de la vía urinaria proximal y edema perirrenal. Su sedimento de orina muestra 40 leucocitos por campo, bacterias y cristales en moderada cantidad. Se inicia tratamiento antibiótico endovenoso y se administran cristaloides. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Litotripsia extracorpórea
B) Nefrolitotomía percutánea
C) Extracción quirúrgica abierta
D) Catéter doble jota
E) Litotomía ureteroscópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una pionefrosis, en contexto de una PNA más litiasis. Se debe drenar con un catéter doble J o "pig tail". Si no es posible instalarlo, se debe realizar una nefroctomía percutánea.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 82 4.03.1.020 · Quistes del epidídimo

Un paciente de 21 años, sin antecedentes, mientras jugaba futbol sufre golpe en zona testicular tras lo cual se palpa una masa. Al examen físico se palpa masa en polo superior blanda. Se solicita ecografía escrotal que muestra lesión quística en epidídimo de 3 cm de díametro, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Orquiectomía por vía inguinal
B) Punción y aspiración del quiste
C) Orquiectomía por vía escrotal
D) Observación
E) Indicar inhibidores de la 5 alfa reductasa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Observación** (opción **D**). Es un quiste del epidídimo. Se observan.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 124 4.03.1.020 · Quistes del epidídimo

Un paciente de 18 años, asintomá8co, se palpa un tumor intraescrotal derecho, por lo que consulta. Al examen Fsico se palpa una tumoración extrates8cular de 1,5 cm de diámetro, de consistencia elás8ca, indolora a la palpación. Se solicita ecograFa escrotal que muestra parénquima tes8cular de aspecto normal, sin lesiones y se visualiza una lesión hipoecogénica de paredes finas, de 1,5 cm de diámetro, en relación con la cabeza del epidídimo derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar orquiectomía radical
B) Realizar resección quirúrgica de la lesión del epidídimo
C) Realizar punción de la lesión
D) Indicar autoexamen tes2cular frecuente
E) Controlar ecográficamente en un año

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece un quiste del epidídimo (se llama espermatocele si es mayor a 2 cm). Suele observarse. El autoexamen testicular no cuenta con evidencia y la mayoría no lo recomienda.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 90 4.03.4.003 · Pielo TAC

Hombre de 45 años con dolor lumbar derecho irradiado a la región inguinal, tipo cólico, de inicio súbito. Uroanálisis: microhematuria, sin piuria. Urocultivo pendiente. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Ecografía renal y de vías urinarias
B) Resonancia magnética
C) UroTAC (PieloTAC sin contraste)
D) Radiografía simple de abdomen
E) Cintigrafía renal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cólico renal (ureterolitiasis): UroTAC sin contraste es el gold standard diagnóstico (sensibilidad 97%, especificidad 96%). Detecta cálculos de cualquier composición, localización y tamaño. La ecografía renal es alternativa inicial (menos sensible para uréteres).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 50 4.03.4.003 · Pielo TAC

Un paciente presenta dolor lumbar intenso, irradiado a testículo, que se ha asociado a vómitos y a inquietud psicomotora. Su sedimento de orina muestra microhematuria. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico en este paciente?

A) TAC de abdomen con contraste
B) Ecografía abdominal
C) PieloTAC
D) Pielografía de eliminación
E) Radiografía simple de abdomen y pelvis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **PieloTAC** (opción **C**). El pielo TAC es de elección para el cólico renal. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 129 4.03.4.003 · Pielo TAC

Un paciente de 18 años, sin antecedentes, consulta por dolor en flanco izquierdo de 1 hora de evolución tipo cólico e irradiado a genitales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita sedimento de orina muestra 50 eritrocitos por campo, sin dismorfia. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Tomografía axial computada con contraste
B) Pielografía de eliminación
C) Radiografía de abdomen
D) Ecografía abdominal
E) Tomografía axial computada sin contraste

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Tomografía axial computada sin contraste** (opción **E**). El pieloTAC no tiene contraste y es el examen de elección para el cólico renal. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 44 4.03.2.007 · Torsión testicular

Un paciente de 16 años presenta dolor testicular derecho intenso, de inicio súbito, asociado a náuseas. Al examen se palpa el testículo derecho muy doloroso y aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Torsión testicular
B) Torsión de la hidátide
C) Infarto testicular
D) Orquiepididimitis
E) Trombosis de varicocele

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cuadro clásico. Que sea adolescente orienta aún más a torsión testicular, por sobre el de hidátide (niños más chicos).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 158 4.03.2.007 · Torsión testicular

Un paciente de 16 años, sin antecedentes, consulta por dolor testicular que inició hace una hora, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico se aprecia testículo derecho ascendido respecto al contralateral y escaso eritema circundante. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar ecografía testicular
B) Indicar doxiciclina y cirpofloxacino
C) Indicar ketorolaco endovenoso y suspensión testicular
D) Realizar exploración quirúrgica inmediata
E) Solicitar exámenes generales, parámetros inflamatorios y sedimento de orina, luego decidir conducta según resultados

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar exploración quirúrgica inmediata** (opción **D**). Testículo agudo: probable torsión testicular. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 94 4.03.2.007 · Torsión testicular

Un hombre de 16 años presenta dolor testicular intenso, que inició hace 8 horas. Tiene EVA 8/10 y al examen testicular se constata testículo derecho muy doloroso, que no mejora con la suspensión testicular. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibióticos orales
B) Doppler testicular
C) Analgésicos orales
D) Antibióticos endovenosos
E) Exploración quirúrgica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Todo testículo agudo se explora. En este caso, por la edad (adolescente o adulto) y por la clínica, se sospecha una torsión testicular.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 97 4.03.2.007 · Torsión testicular

Un paciente de 19 años consulta por dolor en el testículo izquierdo, de inicio brusco y que se ha asociado a vómitos y malestar general. Al examen físico se aprecia testículo izquierdo edematoso, muy doloroso y ascendido. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar exploración quirúrgica escrotal
B) Realizar ecografía doppler testicular
C) Realizar pieloTAC
D) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
E) Indicar reposo y analgésicos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar exploración quirúrgica escrotal** (opción **A**). Todo testículo agudo se explora. Más aún a esa edad, en que se sospecha una tor- sión testicular.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 91 4.03.2.007 · Torsión testicular

Adolescente de 13 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo, intenso, de 45 minutos de evolución, irradiado a hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está afebril, con escroto enrojecido, testículo retraído y doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta a seguir?

A) Administrar AINES
B) Administrar antibióticos
C) Cirugía
D) Realizar suspensión testicular
E) Solicitar ecografía testicular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una torsión testicular o al menos es un testículo agudo, que se maneja con exploración quirúrgica.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 137 4.03.2.007 · Torsión testicular

Un paciente de 18 años presenta aumento de volumen escrotal, doloroso, de inicio súbito. La conducta más adecuada es:

A) Antibióticos orales
B) Punción escrotal
C) Antiinflamatorios orales
D) Exploración quirúrgica
E) Ecografía escrotal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Exploración quirúrgica** (opción **D**). Puede se runa torsión testicular, por lo que se debe explorar de inmediato.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 43 4.03.2.009 · Traumatismo uretral

Un paciente de 46 años presenta un accidente, resultando con una fractura de pelvis. Presenta dolor y salida de sangre fresca por la uretra. Además se palpa la próstata ascendida en el tacto rectal y no ha podido orinar. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Pedir un TAC de abdomen y pelvis
B) Solicitar resonancia magnética
C) Realizar cistoscopía
D) Instalar sonda Foley
E) Instalar cistostomía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una sección uretral. Está contraindicada la Sonda Foley y Nelaton. Se instala cistostomía. Se estudia con uretrocistografía retrógrada y no con los exámens que ahí aparecían. Se resuelve luego con cirugía.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 61 4.03.2.009 · Traumatismo uretral

Un paciente de 24 años sufre un accidente de tránsito a alta velocidad. Ingresa adolorido, con sangre fresca por uretra. Está en buenas condiciones, con estabilidad hemodinámica y sin signos de fracturas en el examen físico. La tomografía axial computada de tórax abdomen y pelvis muestra fractura de pelvis no desplazada, vejiga distendida, sin líquido libre peritoneal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Pielografía de eliminación
B) UroTAC
C) Uretrocistografía retrógrada
D) Ecotomografía pélvica
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una sección uretral, por lo que se contraindica la sonda Foley, se estudia con UCG retrógrada, se maneja con cistostomía suprapúbica y, además, con cirugía de reparación uretral.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 90 4.03.2.009 · Traumatismo uretral

Un paciente de 42 años sufre un accidente automovilístico, resultado con múltiples traumatismos. Al examen físico tiene movilidad de las extremidades inferiores, sin signos de fractura y examen genital con uretrorragia. Las radiografías confirman una fractura de pelvis estable. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Pielografía de eliminación endovenosa
B) Uretrocistografía retrógrada
C) Cistoscopía
D) TAC de pelvis
E) Resonancia magnética nuclear de pelvis RECONSTRUCCIÓN EUNACOM DICIEMBRE 2019 Dr. Guillermo Guevara Aliaga SEGUNDA PARTE Pregunta 181) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdadera?

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una sección uretral, la que se estudia con UCG y se trata con cirugía. Recordar que está contraindicada la sonda (también la cistoscopía) y si hay globo vesical se maneja con cistostomía suprapúbica. Segunda parte

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 66 4.03.2.009 · Traumatismo uretral

Un paciente de 72 años, con antecedente de resección transuretral reciente por hiperplasia prostática benigna, lleva 10 horas con dificultades para orinar. Además, hace 8 horas no ha presentado más evacuaciones de orina. Se intenta instalar una sonda Foley, sin embargo, solo se logra cateterizar hasta la uretra bulbar, encontrando un tope infranqueable. Evoluciona con dolor y uretrorragia. Al examen físico, se palpa globo vesical. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?

A) Ecografía pélvica
B) Tomografía axial computada de pelvis
C) UroTAC
D) Radiografía de pelvis
E) PieloTAC

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ecografía pélvica). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Tomografía axial computada de pelvis, UroTAC) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 85 4.03.5.002 · Cistoscopia

Una paciente de 54 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de disuria, polaquiuria y dolor abdominal bajo. Sus urocultivos repetidos han resultado negativos. Al examen físico tiene mucosa vaginal seca y pálida. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
B) Solicitar cistoscopía
C) Solicitar ecografía transvaginal
D) Indicar estrógenos tópicos
E) Iniciar antimicóticos orales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta discutible, ya que tiene la historia de una cistitis intersticial (se estudia con cistoscopía) y también la de atrofia genital (se trataría con estrógenos tópicos). El dolor abdominal bajo y la polaquiuria sugieren mucho más una cistitis intersticial.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 45 4.03.5.002 · Cistoscopia

Un paciente de 68 años, fumador de 20 paquetes-año, presenta hematuria abundante, con coágulos. Se realiza un sedimento que muestra incontables glóbulos rojos y un urocultivo que resulta negativo. Se le realiza un TAC de abdomen y pelvis que no muestra alteraciones. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir con el estudio en este paciente?

A) Ecografía pélvica
B) Resonancia magnética nuclear
C) Pielografía de eliminación
D) Cistoscopía
E) Uretrocistografía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Probable cáncer de vejiga. La pregunta es difícil, porque el orden a estudiar ese tipo de hematuria es: Sedimento/ urocultivo, luego Eco y luego la cistoscopía. Sin embargo a este paciente le hicieron un TAC y con eso igual se descartan las alteraciones renales. Por tanto no es necesaria la eco.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 46 4.03.1.022 · Tumor renal

Un paciente de presenta dolor abdominal en el flanco izquierdo, por lo que se realiza una ecografía abdominal, que muestra un tumor renal sólido, de 2,5 cm de diámetro, en el polo superior del riñón derecho. Se solicita un TAC, que confirma el tumor renal de aspecto sólido y que capta contraste. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Nefrectomía radical
B) Nefrectomía parcial
C) Nefroureterectomía
D) Iniciar inhibidores de la tirosinasa
E) Realizar seguimiento ecográfico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Todo tumor renal sólido (con pocas excepciones) se presume un cáncer renal. Si son menores a 7 cm (antes era 4), se tratan con nefrectomía parcial (más aún en monorrenos o insuficientes renales). Si son más de 7 cm se tratan con nefrectomía radical. Si tienen metástasis ganglionares, van a terapia paliativa (la inmunoterapia puede servir, pero poco y es muy cara). Si es de pelvis renal, se hace nefroureterectomía.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 121 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Una paciente de 60 años presenta incon8nencia urinaria de 2 años de evolución, caracterizada por escapes de orina precedidos por urgencia miccional incontrolable, por lo que u8liza 3 a 5 protectores al día. Su examen Fsico es normal, al igual que su exploración ginecológica. Se solicita una ecograFa abdominal que muestra vía urinaria de calibre normal y vejiga urinaria sin lesiones, con residuo postmiccional de 30 cc. ¿Qué fármaco es más adecuado como tratamiento de primera línea?

A) Bloqueadores alfa adrenérgicos
B) Bloqueadores beta adrenérgicos
C) Agonistas adrenérgicos
D) An2colinérgicos muscarínicos
E) Estrógenos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una inconGnencia de urgencia. Se trata con medidas de conductuales y de reeducación vesical más kinesioterapia pélvica. De segunda línea, se pueden usar fármacos. Los más usados son los anticolinérgicos (oxibuGnina, tolterodina, cloruro de trospio), por lo que los dejaremos como respuesta correcta. Sin embargo, los agonistas beta 3 adrenérgicos (vivegrón y miravegrón) son una excelente y segura opción, aunque son caros y están poco disponibles en Chile. En adultos mayores, los anticolinérgicos se asocian a desarrollo y agravamiento de demencia, por lo que se prefiere el cloruro de trospio (traspasa menos la barrera hematoencefálica) y o los beta 3 adrenérgicos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 101 · 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Una paciente de 56 años presenta incontinencia urinaria, con escapes de orina, en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. En ocasiones, también presenta escapes de orina en la noche. Al examen no presenta pérdida de orina con la maniobra de Valsalva y no tienen otras alteraciones. Sus urocultivos son negativos y su sedimento de orina es normal. Se solicita una ecografía que muestra vejiga de paredes delgadas, sin cálculos ni residuo postmiccional significativo. El tratamiento más adecuado es:

A) Iniciar tamsulosina
B) Iniciar oxibutinina
C) Realizar cistoscopía
D) Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
E) Indicar ejercicios de kinesioterapia pélvica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una incontinencia urinaria de urgencia, primero se debe descartar ITU y luego se trata con cambios conductuales y anticolinérgicos (tolterodina y oxibutinina). Esta es una de las preguntas que hace pensar que para el Eunacom se deben marcar los anticolinérgicos de inmediato en el manejo de la IOU.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 79 · 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Una mujer de 73 años, presenta escapes de orina, precedidos por grandes e incontrolables deseos de orinar. Además, ha tenido escapes de orina en la noche. Al examen físico, no hay mayores alteraciones. Se solicita una ecografía vesical, que visualiza una vejiga urinaria de paredes delgadas, sin litiasis y sin residuo postmiccional significativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cistoscopía
B) Realizar suspensión uretral con cinta transvaginal
C) Iniciar oxibutinina
D) Indicar ejercicios de piso pélvico
E) Realizar cirugía abierta de piso pélvico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una incontinencia de orina de urgencia, que se trata preferentemente con anticolinérgicos, como la oxibutinina. 80 La verdad es que esta pregunta no la recuerdo bien. Sí recuerdo que tenía una HPB y una clínica de IOU. En general, la HPB con complicaciones, se trata con RTU (creo que no aparecía en las alternativas) y el tratamiento de primera línea de la HPB suele ser la tamsulosina. Además, la IOU se trata con anticolinérgicos (oxibutinina, cloruro de trospio y tolteridina), pero como aparecía más de uno, creo que querían que se marcara la tamsulisina. Insisto, no recuerdo bien esta pregunta.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 48 · 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Una paciente de 69 años diabética, mal controlada, presenta escapes de orina. Adema ha presentado algunas infecciones urinarias. Su urocultivo actual está negativo, pero consulta por la incontinencia urinaria. Se realiza una ecografía que muestra una vejiga de paredes lisas, con volumen urinario de 930cc y residuo postmiccional de 750cc. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Resolver quirúrgicamente
B) Instalar una sonda Foley
C) Realizar cateterismo intermitente
D) Indicar anticolinérgicos
E) Indicar colinérgicos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una vejiga neurogénica (por neuropatía diabética). Se tratan con autocateterismo limpio (no estéril, sino limpio) intermitente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 71 · 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Una paciente de 37 años presenta escapes de orina, en grandes cantidades, precedidos por deseos incontrolables de orinar. Su examen físico no aporta mayor información. Su urocultivo es negativo y su desimento de orina no presenta alteraciones. Se solicita una cistomanometría que muestra contracciones no inhibidas del detrusor, que aparecen entre los 80 y 100 cc de llenado vesical. El tratamiento inicial más adecuado es:

A) Anticolinérgicos
B) Bloqueadores alfa 1 adrenérgicos
C) Cirugía
D) Kinesioterapia pélvica
E) Reducación vesical

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy discutible, ya que, si bien está claro que tiene una incontinencia urinaria de urgencia, tanto los anticolinérgicos, como la terapia conductual (reeducación vesical sería lo más similar a ello) son tratamientos adecuados. Como se pregunta el tratamiento inicial, yo marqué la E, siguiendo las recomendaciones norteamericanas. Pero, la verdad, es que aquello es discutido por las asociaciones de especialistas luego de conversarlo mucho con varios especialistas, ellos recomiendan marcar la A, por ser claramente de urgencia. En fin... lo importante es no pelear con el Eunacom y seguir respondiendo.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 49 · 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Una paciente de 81 años, multípara de 3, histerectomizada, inicia escapes de orina de esfuerzos hace 5 años y además, desde hace 2 años tiene escapes de urgencia. No tie- ne antecedente de infecciones urinarias, ni hematuria. Al examen físico se aprecia un grado leve de prolapso genital. Se realiza sedimento de orina con 4-5 leucocitos por campo y 2-3 hematíes por campo, sin bacterias y se realiza un urocultivo, que resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar tratamiento quirúrgico del prolapso
B) Indicar ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico
C) Iniciar anticolinérgicos
D) Iniciar alfabloqueadores adrenérgicos
E) Solicitar ecografía abdomino-pélvica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta rara, ya que mezcla la IOE, con la IOU. De todos modos, al predominar la IOE, lo primero es intentar los ejercicios de piso pélvico.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 76 · 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Una mujer de 65 años de edad, multípara de 4, con todos los partos por vía vaginal, con menopausia a 50 años, sin terapia de reemplazo hormonal, presenta escape de pequeñas cantidades de orinal, al realizar esfuerzos, así como al toser o reírse, lo que la obliga a usar protectores. No tiene urgencia miccional. Su examen físico no aporta mayor información, pero es posible visualizar leve escape de orina, al toser. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esta paciente?

A) Cirugía (TVT)
B) Anticolinérgicos
C) Alfa adrenérgicos
D) Kinesioterapia del piso pélvico
E) Antibióticos, como profilaxis de ITU

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una incontinencia de esfuerzo, cuyo tratamiento inicial son los ejercicios de Kegel. Si fallan, se indica el TVT o TOT (cirugía).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 112 · 4.03.1.014 · Incontinencia urinaria

Paciente adulta mayor con cuadro clásico de incontinencia urinaria de esfuerzo, conducta: a. Kinesioterapia pélvica

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Amoxicilina** (opción **A**). La fístula vesico-vaginal, típicamente postquirúrgica tras histerectomía o cesárea, produce goteo urinario continuo; se diagnostica con uretrositografía y el tratamiento es quirúrgico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 6 · 4.03.1.015 · Infección urinaria alta y

Se a8ende a una paciente de 26 años con antecedente de infecciones del tracto urinario a repe8ción desde hace 4 años, coincidiendo con el inicio de sus relaciones sexuales. Ha presentado urocul8vos posi8vos para Escherichia coli con una frecuencia de 5 a 6 episodios por año. Su examen Fsico actual es normal, el urocul8vo es nega8vo y el panel de PCR para infecciones de transmisión sexual también resulta nega8vo. Una ecograFa renal y vesical previa resultó normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cistoscopía
B) Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina
C) Iniciar flavoxato vía oral
D) Profilaxis an2bió2ca poscoital
E) Indicar uso de preserva2vo durante las relaciones sexuales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las ITU recurrentes se deben 1. Confirmar con urocultivo, 2. Estudiar en búsqueda de una causa tratable y 3. Manejar con profilaxis antibiótica, hasta resolver la causa de base. Si hay clara relación con acGvidad sexual, la profilaxis antibiótica poscoital disminuye las recurrencias.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 108 · 4.03.1.015 · Infección urinaria alta y

Mujer de 25 años con infecciones urinarias recurrentes (>3 episodios/año) claramente asociadas a relaciones sexuales. ¿Cuál es la profilaxis más adecuada?

A) Nitrofurantoína 50 mg o cotrimoxazol post coito
B) Ciprofloxacino 500 mg diario indefinido
C) Amoxicilina 500 mg diario
D) Solo higiene y micción postcoital
E) Vacuna anti-E. coli

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
ITU recurrente postcoital: profilaxis antibiótica postcoito con una dosis única de nitrofurantoína 50-100 mg o cotrimoxazol 480 mg reduce recurrencias en >95% de los casos.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 93 · 4.03.1.015 · Infección urinaria alta y

Mujer de 55 años con ITU a repetición (>3 episodios/año) que recibe profilaxis con nitrofurantoína. Tiene antecedente de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es el cambio terapéutico más adecuado?

A) Amoxicilina profiláctica
B) Cefalexina profiláctica
C) Cotrimoxazol profiláctico
D) Suspender profilaxis y observar
E) Mantener nitrofurantoína sin cambios

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Nitrofurantoína está contraindicada en fibrosis pulmonar (puede agravar la enfermedad pulmonar y causa toxicidad pulmonar crónica). Cambio a cotrimoxazol (trimetoprim-sulfametoxazol) profiláctico postcoital o cíclico es la alternativa de elección para ITU recurrente.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 4 · 4.03.1.015 · Infección urinaria alta y

Pregunta 4 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente se realiza una cirugía transuretral hace 7 días. Evoluciona con disuria dolorosa, asociada a malestar general y fiebre hasta 38,7 grados Celsius. Se realiza un sedimento de orina con leucocituria de 50 por campo y abundantes bacterias, y un urocultivo, que resulta positivo para Pseudomona aureginosa y el antibiograma está pendiente. El tratamiento de elección es:

A) Amoxicilina-clavulánico
B) Nitrofurantoína
C) Cotrimoxazol
D) Imipenemen
E) Ceftriaxona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Imipenemen** (opción **D**). De las opciones que aparecían, el imipenem era el único con cobertura para Pseudomona.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 51 · 4.03.1.015 · Infección urinaria alta y

Un paciente de 81 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, usuario de Sonda Foley a permanencia, se realiza un urocultivo, porque sus orinas se han vuelto turbias. Dicho urocultivo resulta positivo para Escherichia coli, con más de 100.00 UFC, sensible a nitrofurantoína, gentamicina e imipenem. ¿Cuál de las siguientes actitudes es la más adecuada?

A) Observar evolución
B) Indicar tratamiento con imipenem
C) Indicar tratamiento con gentamicina
D) Indicar tratamiento con nitrofurantoína
E) Retirar la sonda

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy muy difícil. La bacteriuria asintomática no debe ser tratada en los pacientes con sonda, de hecho ni siquiera se deben pedir urocultivos, así la respuesta sería observar. Pero el paciente tiene Alzheimer y por tanto no sabemos si tiene síntomas de infección urinaria. Si fuera una ITU baja, se debe evaluar retirar la sonda y además tratar con ATB. Creo que será correcta observar. De lo contrario, retirar la sonda, pero la verdad es que la pregunta no es para médico general y probablemnete no estarán de acuerdo los mismos especialistas entre ellos.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 20 4.03.1.019 · Malformaciones congénitas

Un recién nacido, con antecedente de pielectasia bilateral, diagnosticada por ecografía obstétrica, presenta retraso en la eliminación de orina, por lo que se realiza una ecografía abdominal al tercer día de vida, que visualiza hidroureteronefrosis bilateral, asociada a una vejiga de paredes engrosadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Valvas uretrales posteriores
B) Síndrome de Prune Belly
C) Reflujo vésico-ureteral
D) Vejiga neurogénica
E) Megauréter congénito

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La dilatación bilateral, más la vejiga de lucha orienta a obstrucción uretral. La única opción era la de las valvas/válvulas uretrales, que son una malformación relativamente frecuente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 159 4.03.1.003 · Cáncer de vejiga y uroteli

Paciente femenina, fumadora de 30 paquetes/año, presenta hematuria, con abundante coágulos de sangre. No presenta dolor, fiebre, ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes eritrocitos, sin bacterias. El diagnóstico más probable es:

A) Cistitis hemorrágica
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer renal.
D) Tuberculosis renal
E) Infección urinaria

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El cáncer de vejiga es la causa más frecuente de hematuria monosintomática (sin otros síntomas; si en cambio viene con síntomas de ITU, es ITU; si viene con síntomas de litiasis, es litiasis, etc.) en el adulto, en especial si es un paciente fumador. Las demás opciones tienen otros síntomas. La clínica clásica del cáncer renal es: masa, hematuria y fiebre (más ictericia en algunos casos).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 77 4.03.1.003 · Cáncer de vejiga y uroteli

Un paciente de 67 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, consulta por hematuria de 4 días de evolución, abundante, con coágulos. No ha presentado disuria, ni poliaquiuria, ni mal olor en la orina, ni dolor. Su examen de orina muestra abundantes eritrocitos por campo, sin

A) Cáncer renal
B) Cáncer de vejiga
C) Cáncer de uréter
D) Cáncer de próstata
E) Cistitis intersticial

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La hematuria monosintomática del adulto sugiere un cáncer de vejiga. El antecedente de fumar, también.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 75 4.03.1.017 · Infertilidad masculina

Un hombre de 33 años, lleva 18 años intentando concebir un hijo con su pareja. Ella tiene reglas regulares y él tiene un examen físico y genital normal. ¿Con qué examen debemos iniciar el estudio en este paciente?

A) LH
B) FSH
C) Espermiograma
D) Cultivo de líquido seminal
E) Ecografía testicular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Espermiograma). El primer estudio de infertilidad masculina es el espermiograma.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 43 4.03.1.017 · Infertilidad masculina

Una pareja consulta por infertilidad de 2 años de evolución. Ella no tiene anteceden- tes de importancia y tanto su examen físico, como exploración ginecológica son norma- les. Él realiza ciclismo de montaña y en su examen físico se constatan testículos de ta- maño pequeño, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el primer examen para evaluarlo?

A) Espermiograma
B) Ecografía testicular
C) Niveles plasmáticos de LH, FSH y testosterona
D) Niveles plasmáticos de TSH, prolactia
E) Biopsia testicular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El espermiograma es el examen de elección para el inicio del estudio de la infertili- dad masculina.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 41 4.03.5.001 · Biopsia prostática

Un paciente de 85 años presenta APE de 7,5 ng/ml. Está asintomático y no tiene an- tecedente de infecciones urinarias. Su tacto rectal demuestra una próstata sin nódulos,

A) Realizar cintigrafía ósea
B) Realizar TAC de pelvis
C) Realizar RMN de pelvis
D) Realizar biopsia prostática
E) Iniciar finasteride oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
A los 85 años, jamás se debió haber pedido el APE. Es una mala pregunta. En las opciones no salía observar. Dado que todo APE mayor a 4,0 se biopsia, creo que la res- puesta es la D.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 78 · 4.03.5.001 · Biopsia prostática

Un paciente de 60 años, que durante una infección urinaria, se detectó APE de 14,2 ng/ml y un tacto rectal, con presencia de un nódulo prostático duro. Una vez tratada con éxito su infección, el APE es bajó a 12 ng/ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Prostatectomía radical
B) Seguimiento con APE y tacto en 1 año
C) Ecografía de próstata
D) Resección transuretral
E) Biopsia prostática

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Biopsia prostática** (opción **E**). Tanto por el nódulo, como por el APE mayor a 4, está indicada la biopsia.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 148 · 4.03.1.028 · Varicocele

Un adolescente de 15 años presenta dolor frecuente del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa aumento de volumen perotesticular, compatible con un varicocele y además se palpa el testículo izquierdo de menor tamaño que el testículo derecho. Se solicita una ecografía testicular que muestra una dilatación patológica del plexo pampiniforme.

A) Observa evolución hasta que complete su desarrollo puberal
B) Realizar varicosectomía
C) Solicitar espermiograma
D) Realizar biopsia testicular
E) Solicitar cariograma y niveles de testosterona, LH y FSH

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene indicación de ligadura del plexo pampiniforme, tanto por la atrofia testicular, como por el dolor.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 55 · 4.03.1.008 · Estenosis uretral

Un paciente masculino, de 30 años, consulta por diminución del calibre miccional, asociada a disuria de esfuerzo de varios meses de evolución. Tiene antecedente de un trauma perineal hace 3 años atrás. Al examen físico tiene genitales externos normales y su tacto rectal demuestra una próstata pequeña y blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer de próstata
B) Uretritis
C) Hiperplasia prostática benigna
D) Estenosis uretral
E) Urolitiasis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Parece una estenosis uretral postraumática. Dada la edad y el tacto rectal, es im- probable que sean las demás causas de UOB.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 162 · 4.03.1.024 · Tumor testicular

Un paciente de 30 años consulta por aumento de volumen escrotal derecho. Al exa- men físico se palpa un tumor en relación al testículo derecho. Se solicita ecografía testi- cular que visualiza una lesión sólida, de 3 cm de diámetro, sin vascularización, que re- emplaza al parénquima testicular, sin compromiso del epidídimo. ¿Cuál es la conducta?

A) Radioterapia
B) Quimioterapia
C) Orquiectomía radical
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Biopsia testicular por punción

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un tumor testicular, confirmado con la ecografía, por lo que se debe realizar la orquiectomía radical, con biopsia excisional.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 179 · 4.03.1.007 · Epididimitis

Un paciente de 60 años fue tratado hace 7 días con ciprofloxacino, por disuria. Hace dos días presenta dolor testicular izquierdo, asociado a fiebre. Al examen físico tiene aumento de volumen testicular, con dolor a la palpación, especialmente del conducto espermático. Se observa ligero edema escrotal, con eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hidrocele
B) Varicocele
C) Torsión testicular
D) Tumor testicular
E) Orquiepididimitis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Orquiepididimitis** (opción **E**). Es una orquiepididimitis clásica.. La orquiepididimitis es una infección del epidídimo que puede extenderse al testículo, produciendo un cuadro inflamatorio e infeccioso que hay que diferenciar del testículo agudo por torsión. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 175 · 4.03.1.007 · Epididimitis

Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa au- mento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pyogenes
B) Staphilococcus aureus
C) Chlamydia trachomatis
D) Neisseria gonorreae
E) Escherichia coli

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

E? La clásica causa de orquiepididimitis es la infección por clamidia y luego gono- rrea (yo marqué Chlamydia). Sin embargo, la E. Coli es la causa más frecuente cuando no hay infección de transmisión sexual y es especialmente frecuente en adultos mayo- res. En este caso, si le creíamos que tenía pareja única, la respuesta probablemente era E. Coli.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 161 4.03.1.007 · Epididimitis

Un paciente de 21 años, sexualmente ac8vo, consulta por dolor y aumento de volumen progresivos en relación al tes`culo izquierdo, que inició hace 5 días y se ha asociado a disuria y escasa secreción uretral. Al examen Fsico, presenta frecuencia cardíaca 65 la8dos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg y temperatura axilar de 37,1 °C. El examen genital muestra escroto aumentado de volumen y enrojecido a izquierda; se palpa tes`culo izquierdo ligeramente aumentado de volumen, sin masas, y epidídimo izquierdo con gran aumento de volumen, muy doloroso a la palpación. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

A) Cejriaxona intramuscular
B) Ciprofloxacino oral
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
D) Doxiciclina oral
E) Exploración quirúrgica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una orquiepididimiGs y uretriGs, que en pacientes sexualmente activos suele deberse a infección por Clamydia trachoma9s (se trata con doxiciclina VO de elección) o Neisseria gonorrhoeae (se trata con cemriaxona IM de elección). Entre ambas, la clínica subaguda, con secreción escasa orienta más a una infección por Chlamydia. En un paciente real es razonable cubrir ambas bacterias (ej. doxicilina 100 mg/12 h por 10 días VO + cemriaxona 500 mg IM por una vez). La azitromicina es una opción subópGma (1 g para clamidia y 2 g para gonococo).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 112 4.03.1.005 · Disfunción sexual de causa

Hombre de 55 años con disfunción eréctil de 6 meses de evolución, sin causa aparente. HTA controlada con enalapril. Sin síntomas de hipogonadismo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (sildenafil o tadalafil)
B) Testosterona intramuscular
C) Alprostadil intracavernoso
D) Prótesis de pene
E) Solo consejería psicológica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Disfunción eréctil: primera línea = inhibidores de PDE5 (sildenafil, tadalafil). Contraindicados con nitratos. Enalapril no contraindica su uso. La testosterona solo si hay hipogonadismo confirmado.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 49 4.03.1.005 · Disfunción sexual de causa

Un paciente de 63 años consulta por impotencia sexual de algunos meses de evolución, que ha avanzado. Tiene antecedente de diabetes de 20 años de evolución. Está preocupado, ya que le ha provocado problemas maritales. El tratamiento más adecuado es:

A) Inyecciones intracavernosas de papaverina
B) Yohimbina
C) Sildenafil
D) Prótesis peneana
E) Psicoterapia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil, ya que el sildenafil está contraindicado por el infarto reciente. De primera línea está el sildenafil, la apomorfina y los dispositivos de vacío (no recuerdo si salía apomorfina). De segunda línea, están las inyecciones intracavernosas de papaverina o prostaglandina. La última línea es la prótesis peneana. La yohimbina y la protsglandina tópica sirven, pero poco.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 32 4.03.1.005 · Disfunción sexual de causa

Un paciente de 68 años, con antecedente de hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial y diabetes, está en tratamiento con tamsulosina, atenolol, hidroclorotiazida, metformina y aspirina. Consulta por dificultades para lograr y mantener la erección, lo que le preocupa. ¿Qué fármaco puede ser el causante de estos síntomas?

A) Aspirina
B) Metformina
C) Hidroclorotiazida
D) Tamsulosina
E) Atenolol

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Atenolol** (opción **E**). Ahora ya saben, el atenolol puede producir impotencia sexual.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 107 4.03.1.005 · Disfunción sexual de causa

Paciente adulto mayor que no lograba erección, libido se conservaba, temor a que su pareja lo deje ya que antes tenían encuentros 1-2 por semana. Conducta:

A) Sildenafil
B) Búsqueda de causa 2ria: tenía líbido conservada, no describe ansiedad ante su performance, me parece relevante descartar causas secundarias (p ej diabetes) antes de asumir q su problema es psicológico c. Terapia psicológica (justifiquen cada una)
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno de estrés postraumático

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Sildenafil** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Búsqueda de causa 2ria: tenía líbido conserva, Trastorno de ansiedad generalizada) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 113 4.03.1.005 · Disfunción sexual de causa

Hombre de 30 años con eyaculación que ocurre antes o dentro del minuto de la penetración en el 90% de los encuentros, con angustia y evitación de relaciones. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Dapoxetina (ISRS de acción corta) + técnicas conductuales (stop-start)
B) Alprazolam previo al coito
C) Testosterona intramuscular
D) Sildenafil
E) Antidepresivos tricíclicos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Eyaculación precoz primaria: tratamiento combinado con ISRS (dapoxetina o paroxetina a demanda) + terapia conductual (técnica stop-start o squeeze) tiene la mejor tasa de éxito.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 101 4.03.2.005 · Prostatis aguda

Un paciente de 56 años consulta por disminución del calibre miccional, asociado a disuria de esfuerzos de 3 meses de evolución. Hace 7 días se agrega disuria, polaquiuria y malestar. Se solicita APE, que resulta 14,7 ng/ml (valor normal: menor a 4 ng/ml). El tratamiento inicial más adecuado es:

A) Tamsulosina
B) Nitrofurantoína
C) Ciprofloxacino
D) Dutasteride
E) Doxazosina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una prostatitis aguda, por la clínica de ITU e importante elevación del APE. Se trata con ciprofloxacino. Se puede estudiar con cultivo de líquido seminal. Luego de tratarla, se debe esperar a repetir el APE.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 48 4.03.2.005 · Prostatis aguda

Un hombre de 50 años consulta por disuria dolorosa y fiebre, asociada a malestar general, polaquiuria y dolor perineal. Al examen físico presenta fiebre alta, con hemodinamia estable. Se realizan exámenes entre los que destacan sedimento de orina con leucocitos +++, bacterias ++. Su urocultivo está pendiente. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Ciprofloxacino
B) Amoxicilina
C) Claritromicina
D) Nitrofurantoína
E) Doxiciclina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Ciprofloxacino** (opción **A**). No queda claro si es una prostatitis aguda o una ITU, pero el ciprofloxacino las cubre a ambas.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 62 4.03.2.004 · Priapismo

Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen se corrobora que tiene erección completa, pero turgencia solo de los cuerpos cavernosos, con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Aplicar hielo en la zona genital
B) Realizar derivación cavernoesponjosa de urgencia
C) Administrar atropina intracavernosa
D) Administrar analgésicos endovenosos
E) Administrar fenilefrina intracavernosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El priapismo isquémico (erección dolorosa y mayor a 4 horas, que suele perder la turgencia del glande y cuerpo esponjoso) es una urgencia y se maneja en primer lugar con fenilefrina intracavernosa, seguido luego de manejo invasivo con drenaje y lavado con SF de los cuerpos cavernosos y, si falla, con derivación cavernoesponjosa. También se deben buscar causas secundarias (ej. drepanocitosis o leucemia) y, además, distinguirlo del priapismo de alto flujo o no isquémico (que es por hiperflujo arterial y generalmente no duele ni tiene riesgo de complicarse con disfunción eréctil permanente, por lo que se observa o maneja con compresas de hielo para acelerar su desaparición).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 66 4.03.2.004 · Priapismo

Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen tiene cuerpos cavernosos duros, pero con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Aplicar paños fríos en la zona genital
B) Fenilefrina endovenosa
C) Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos.
D) Drenaje con suero fisiológico frío intracavernoso
E) Fenilefrina intracavernosa Respuesta: (Nota: La imagen se corta antes de mostrar la explicación o la respuesta correcta, pero la conducta inicial para un priapismo isquémico suele ser el drenaje y la inyección de fenilefrina intracavernosa).

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Vaciamiento quirúrgico de los cuerpos cavernosos.** (opción **C**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 94 4.03.2.004 · Priapismo

Un paciente de 24 años, con antecedente de consumo frecuente de cocaína, presenta dolor peneano de 5 horas de evolución asociado a una erección constante. Al examen Fsico se obje8va erección de los cuerpos cavernosos, con flacidez del glande y el cuerpo esponjoso. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Administrar adrenalina intracavernosa
B) Propranolol vía oral
C) Doxasozina vía oral
D) Derivación cavernoesponjosa quirúrgica
E) Administrar fenilefrina intracavernosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un priapismo isquémico o verdadero (erección dolorosa y mantenida, limitada a los cuerpos cavernosos). El tratamiento sigue el siguiente orden: 1. Fenilefrina intracavernosa, 2. Procedimientos invasivos (drenaje de los cuerpos cavernosos con suero fisiológico o derivación cavernoesponjosa). Además, se debe buscar la presencia de leucemia y anemia de células falciformes (rara en Chile), aunque en este caso la causa más probable parece estar relacionada con el consumo de cocaína.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 66 4.03.2.004 · Priapismo

Un hombre de 34 años presenta erección dolorosa, desde hace 8 horas. Al examen tiene erección completa, pero turgencia solo de los cuerpos cavernosos, con glande y cuerpos esponjosos blandos. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Aplicar paños hielo en la zona genital
B) Realizar derivación cavernoesponjosa
C) Administrar atropina intracavernosa
D) Administrar analgésicos
E) Administrar fenilefrina intracavernosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El priapismo (erección dolorosa mayor a 4 horas, con pérdida de turgencia del glande y cuerpo esponjoso) se trata con fenilefrina intracavernosa, como primera línea.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 74 4.03.1.012 · Hidronefrosis

Un paciente de 18 años consulta por dolor lumbar izquierdo, de larga evolución. Al examen físico tiene una masa en el flanco izquierdo, por lo que se solicita una ecografía abdominal, que muestra una hidronefrosis izquierda, con adelgazamiento de la corteza renal, sin dilatación uretral. Su creatinina plasmática es 0,9 mg/dl y su sedimento de orina no presenta alteraciones. La cintigrafía renal muestra captación de 90% a derecha y 10% a izquierda. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar pieloplastía izquierda
B) Realizar nefrostomía percutánea
C) Realizar nefrectomía izquierda
D) Instalar sonda Foley
E) Solicitar pieloTAC

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy discutible y de manejo de especialista, que no debería preguntarse. Que tenga solo 10% de captación y adelgazamiento cortical muestra que el riñón probablemente tiene daño severo e irrecuperable, por lo que estaría indicada la nefrectomía. Eso sí, antes debería pedirse una TAC, ya que igual se puede intentar salvar ese 10% con una pieloplastía. Discutimos mucho esta pregunta con varios especialistas y aunque no hubo consenso, dejaremos como correcta la nefrectomía. Nuevamente, en fin... así es el Eunacom y lo más importante es no pelear con él, sino seguir respondiendo.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 125 4.03.2.008 · Trauma urológico

Un paciente de 35 años sufre un traumatismo lumbar de alta energía, evolucionando con hematuria. Al examen físico está hemodinámicamente estable, con FC: 75x' y PA: 120/80 mmHg. ¿Cuál es el examen de elección para precisar el diagnóstico?

A) PieloTAC
B) UroTAC
C) Radiografía de abdomen simple
D) Ecografía renal
E) Pielografía de eliminación

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un traumatismo renal (golpe lumbar más hematuria), que se estudia con el Uro TAC. No confundir con la lesión uretral (golpe pélvico más uretrorragia), que se estudia con la UCG.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 83 4.03.2.008 · Trauma urológico

Paciente con trauma en región lumbar + hematuria, examen de elección:

A) urotac
B) Eco renal y pélvica
C) Laparotomía exploratoria
D) Cirugía laparoscópica
E) Manejo conservador

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (urotac). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Eco renal y pélvica, Laparotomía exploratoria) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 170 4.03.1.025 · Urolitiasis

Un paciente de 42 años presenta eliminación de un cálculo en orina, el cual no pudo recuperar para análisis. Se realiza estudio metabólico en orina de 24 horas con calcio, fósforo, citrato y uratos, todos dentro del rango normal, al igual que su perfil bioquímico en sangre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la ingesta de agua
B) Iniciar alopurinol oral
C) Realizar litrotricia extracorpórea
D) Indicar dieta baja en lácteos
E) Indicar dieta rica en vegetales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Prevención de la Litiasis Urinaria: La medida más importante para prevenir la formación de cálculos renales es aumentar la ingesta de agua. Dependiendo del tipo de cálculo y las alteraciones metabólicas, se pueden recomendar medidas adicionales como tiazidas para la hipercalciuria, alopurinol para la hiperuricemia/hiperuricosuria, y una dieta baja en proteínas animales para la hiperoxaluria.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 126 4.03.1.025 · Urolitiasis

Un paciente de 54 años ha presentado varios episodios de cólico renal, con eliminación reiterada de cálculos urinarios. Su examen físico no tiene alteraciones. En sus exámenes destaca creatinina: 1,4 mg/dl y examen de orina con pH: 7,9, glóbulos rojos: 15 x campo, glóbulos blancos: 15 por campo, bacterias en moderada cantidad y cristales de fosfato amónico magnésico (estruvita). El pieloTAC muestra presencia de cálculos coraliformes bilaterales. ¿Qué germen es el agente etiológico, con mayor probabilidad?

A) Proteus mirabilis
B) Klebsiella oxytoca
C) Pseudomona aureginosa
D) Campilobacter jejuni
E) Escherichia coli

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El proteus es la causa de los cálculos coraliformes de estruvita. Además, suele alcalinizar la orina.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 150 4.03.1.025 · Urolitiasis

Un paciente de 45 años presenta un cuadro de cólico renal derecho que es manejado con analgesia. Se realiza una pieloTAC, que muestra la presencia de un cálculo de 4 mm en el uréter derecho, el cual se maneja inicialmente con observación. Sin embargo, luego de 4 semanas no ha presentado expulsión del cálculo a pesar de haberse indicado terapia expulsiva con alfabloqueantes hace dos semanas. La pieloTAC de control muestra mayor dilatación de la vía urinaria en dicha zona, con presencia del cálculo descrito, de 4 mm en el uréter distal, que se informa con una dureza de 800 unidades de Hounsfield. La creatinina de control está en 1,38 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener terapia farmacológica expulsiva y controlar en 2 semanas
B) Realizar la instalación de un catéter "doble J"
C) Administrar antibióticos endovenosos
D) Realizar una ureteroscopía
E) Realizar litotricia (litotripsia) extracorpórea

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de Litiasis Urológica: El manejo de la litiasis urológica varía según el tamaño del cálculo: Menor a 5 mm: Observación. Entre 5 y 10 mm: Alfabloqueantes para facilitar la expulsión. Mayor a 10 mm: Litotricia extracorpórea o ureteroscopía. La ureteroscopía se prefiere para cálculos en el uréter distal, cálculos muy duros y en casos donde la litotricia extracorpórea está contraindicada (embarazo, alteraciones de la hemostasia). La litotricia extracorpórea (LEC) se prefiere para cálculos de dureza moderada a baja, en el uréter alto o medio, menores a 2 cm, sin contraindicaciones de LEC.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 64 4.03.1.025 · Urolitiasis

Un paciente de 34 años presenta su primer episodio de cólico renal. Presenta eliminación espontánea de un pequeño cálculo, el que no es preservado para estudio citoquímico. Actualmente está asintomático y el pieloTAC no observa otras litiasis. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este paciente?

A) Indicar dieta baja en lácteos
B) Iniciar hidroclorotiazida
C) Aumentar la ingesta de agua
D) Realizar litotripsia extracorpórea
E) Realizar estudio metabólico de urolitiasis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Para evitar la recidiva de las litiasis siempre es útil aumentar la ingesta de agua, con independencia de la causa. Además, en los casos de hipercalciuria sirven las tiazidas y, en los casos de hiperoxaluria o hiperuricosuria, sirve la dieta. En el caso de ser por estruvita, también se debe tratar con antibióticos.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 11 4.03.1.025 · Urolitiasis

Un paciente de 78 años ha presentado eliminación de cálculos urinarios a repetición. Se solicitan exámenes de orina que muestran sedimento con 20 glóbulos rojos por campo, 12 leucocitos por campo, bacterias en abundante cantidad y cristales abundantes de fosfato de amonio magnesiano. El urocultivo está pendiente. Se solicita una pieloTAC, que muestra cálculos coraliformes bilaterales. El urocultivo, probablemente resultará positivo, ¿para qué bacteria?

A) Pseudomona aureginosa
B) Escherichia coli
C) Campilobacter jejuni
D) Proteus mirabilis
E) Enterobacter cloacae

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Campilobacter jejuni). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Pseudomona aureginosa, Escherichia coli) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 48 4.03.1.025 · Urolitiasis

Un paciente de 83 años, diabético e hipertenso, consulta por dolor en el flanco derecho, asociado a 2 episodios de vómitos alimentarios. En su examen físico, tiene frecuencia cardíaca: 80x', PA: 120/80 mmHg y abdomen sin signos peritoneales. Se solicita TAC de abdomen y pelvis que se muestra a continuación (fuente: Radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Colitis isquémica
B) Pancreatitis aguda
C) Litiasis ureteral
D) Diverticulitis aguda
E) Infarto esplénico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico Diferencial de Cólico Renal: El cuadro clínico sugiere un cólico renal. Sin embargo, en un paciente adulto mayor con factores de riesgo cardiovascular, se debe considerar un aneurisma aórtico abdominal roto. En la imagen, se observa un cálculo en el uréter, confirmando el diagnóstico de urolitiasis.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 101 4.03.1.025 · Urolitiasis

Paciente con litiasis a repetición, orina inflamatoria y cristales de fosfato magnesio amónico con litiasis coraliforme. ¿Qué microorganismo crecerá en el urocultivo?

A) Escherichia coli
B) Klebsiella pneumoniae
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Staphylococcus saprophyticus
E) Proteus mirabilis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Proteus mirabilis). Proteus mirabilis. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 91 4.03.1.025 · Urolitiasis

Paciente con 3 cálculos pequeños, 1 en unión vesicoureteral de 6 mm, los otros eran de 5 y 3 mm. Tenía unos en pelvis renal igual o no??: (según yo todos median mas de 10mm y si habían dos en la pelvis renal) a. Tamsulosina b. Nefrolitotomia

C) LEC
D) Estudio metabólico
C) Hemograma y VHS
D) Ecografía
E) Radiografía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (LEC). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Estudio metabólico, Ecografía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 103 4.03.1.002 · Cáncer de próstata

Paciente de 83 años con APE 10, adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 en 0,3% de la muestra, estudio de diseminación negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Vigilancia activa con control en 3 meses
B) Prostatectomía radical
C) Radioterapia de haz externo
D) Braquiterapia prostática
E) Deprivación androgénica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Vigilancia activa con control en 3 meses** (opción **A**). Vigilancia activa con control en 3 meses. El screening de cáncer de próstata con APE se realiza entre los cincuenta y setenta años; se inicia a los cuarenta en pacientes con antecedentes familiares o mutaciones BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 82 · 4.03.1.002 · Cáncer de próstata

Un paciente de 85 años se realiza un antígeno prostático específico, que resulta 10 mg/dl, razón por la cual es sometido a una biopsia prostática transrectal, que se informa como "presencia de adenocarcinoma prostático, Gleason 3+3, presente en el 0,5% del tejido. El estudio de diseminación resulta negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Prostatectomía radical
B) Radioterapia
C) Observar
D) Braquiterapia
E) Hormonoterapia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Observar** (opción **C**). El screening de cáncer de próstata con APE se realiza entre los cincuenta y setenta años; se inicia a los cuarenta en pacientes con antecedentes familiares o mutaciones BRCA1, BRCA2 o síndrome de Lynch De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 114 · 4.03.1.009 · Fimosis, parafimosis

Un niño de 3 años acude a control sano. Su madre refiere que tiene estrechez del prepucio y, al examen físico, se confirma que el prepucio es irreductible . ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aplicar ungüento antibiótico
B) Realizar tracción manual forzada del prepucio
C) Realizar circuncisión
D) Aplicar ungüento de corticoide tópico
E) Controlar en un año

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Aplicar ungüento de corticoide tópico** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 62 · 4.03.1.009 · Fimosis, parafimosis

Niño de 5 años con incapacidad de retraer el prepucio sobre el glande. Sin dolor ni infecciones previas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Circuncisión electiva inmediata
B) Tranquilizar: fimosis fisiológica normal hasta los 6-7 años; observar
C) Corticoides tópicos en el prepucio
D) Derivar a urología
E) Dilatación manual bajo anestesia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fimosis fisiológica en niño de 5 años es normal; el 90% de los niños tienen prepucio retráctil a los 5 años pero la fimosis es aún fisiológica hasta los 6-7 años. No requiere intervención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 142 · 4.03.4.005 · Uretrocistografía

Paciente con RTU hace 10 años, sin micción hace 8 horas, sonda que no avanza más allá de uretra bulbar con uretrorragia, sin globo vesical. ¿Cuál es el examen de elección?

A) Ecografía pelviana
B) UroTAC sin contraste
C) Uretrografía retrógrada
D) Cistouretrografía miccional
E) Cistoscopía flexible

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Uretrografía retrógrada). Uretrografía retrógrada. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 19 · 4.03.2.006 · Retención urinaria aguda

Hombre de 70 años con HPB conocida llega a urgencias con incapacidad de orinar desde hace 8 horas, vejiga palpable en hipogastrio y dolor intenso. ¿Cuál es el manejo inicial de elección?

A) Sonda Foley vesical
B) Diurético EV
C) Alfa-bloqueador oral y esperar
D) Cistostomía suprapúbica inmediata
E) Cateterismo intermitente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Retención urinaria aguda: manejo inmediato = sonda Foley para drenaje vesical. Alivia el dolor y previene daño renal. Cistostomía solo si falla la sonda. Alfa-bloqueador se agrega DESPUÉS del episodio agudo para prevención de recurrencia.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 5 · 4.03.2.006 · Retención urinaria aguda

Un paciente de 68 años consulta por imposibilidad de orinar asociada a dolor abdominal. Refiere que desde hace 3 días presenta dificultades en la micción que progresaron hasta la anuria en las úl8mas 24 horas. Al examen Fsico se observa sudoroso, con frecuencia cardíaca de 100 lpm y quejumbroso. El examen abdominal demuestra ma8dez a la percusión hipogástrica y dolor a la palpación abdominal baja sin signos peritoneales. Tiene antecedente de una resección transuretral hace 10 años por uropa`a obstruc8va baja asociada a hiperplasia prostá8ca benigna. Se intenta instalar una sonda Foley número 18 por uretra; sin embargo, se encuentra un tope a los 6 cm, con imposibilidad de pasar la sonda y, luego, uretrorragia moderada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cistostomía abierta
B) Intentar instalar una sonda de menor calibre
C) UroTAC
D) Cistostomía suprapúbica
E) Uretrocistogra:a

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se trata de una retención urinaria aguda, probablemente por estenosis uretral (post RTU) o recurrencia de hiperplasia prostática. El manejo inicial es sondaje vesical; sin embargo, al fracasar 2 a 3 intentos o al producirse uretrorragia (sugestiva de lesión uretral o falsa vía), la conducta correcta es realizar una cistostomía suprapúbica percutánea para descompresión vesical. En el caso de sospecha de lesión uretral (ej. fractura de pelvis con uretrorragia), está contraindicada la sonda y se procede directamente a la cistostomía.

OTORRINOLARINGOLOGÍA (ORL)

Módulo 2: Cirugía y Especialidades · Colección Tomo 14

69 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

29 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.03.1.001	Alergia nasosinusal	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.005	Cáncer laríngeo e hipofaríngeo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.007	Diagnóstico diferencial de hipoacusias de transmisión	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.009	Disfonías agudas	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.010	Disfonías crónicas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.013	Estridor laríngeo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.014	Hipoacusia neonatal	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.015	Masa cervical	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.019	Otitis externa	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	7 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.020	Otitis media aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.022	Otitis media crónica y complicaciones	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.023	Patología de glándulas salivales	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.024	Poliposis nasal	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.025	Rinorrea crónica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.026	Rinorreas agudas	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.028	Síndrome respirador bucal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.029	Síndrome vertiginoso	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.030	Sinusopatías crónicas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.1.033	Trastornos de habla y lenguaje	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.002	Absceso periamigdalino	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.03.2.006	Barotrauma ótico y trauma acústico agudo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.009	Cuerpo extraño en vía aérea	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.013	Hematoma nasoseptal	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.016	Perforación timpánica traumática	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.017	Síndrome vertiginoso agudo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.2.018	Sordera súbita	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.4.002	Radiografía de cavum	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.4.006	Audiometría básica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)
6.03.5.015	Traqueostomía y cricoidostomía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 14 · Otorrinolaringología (Pág. 8)

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 148 6.03.1.022 · Otitis media crónica y com

Un paciente de 47 años, con antecedente de perforación 8mpánica derecha de larga data, presenta otalgia y otorrea de dos días de evolución. Al examen Fsico, la otoscopía muestra la perforación 8mpánica conocida, con presencia de secreción amarillenta en relación al `mpano y al conducto audi8vo externo. ¿Qué an8bió8co es de elección para el tratamiento inicial de este paciente?

A) Neomicina tópica
B) Ciprofloxacino tópico
C) Amoxicilina oral
D) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
E) Cejriaxona endovenosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una oGGs media crónica simple, cuyo tratamiento de primera línea es tópico, con ciprofloxacino. La neomicina tópica Gene riesgo de ototoxicidad directa, por ser un aminoglicósido. Los antibióticos sistémicos se usan en los casos complicados (ej. mastoidiGs, laberintiGs). La cirugía está indicada en los casos refractarios y en caso de que haya un colesteatoma asociado.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 104 6.03.1.022 · Otitis media crónica y com

Un paciente de 59 años presenta hipoacusia bilateral, asociado a otorrea, de larga data. Consulta por un cuadro de reciente inicio, de mayor hipoacusia derecha, asociada a vértigo persistente, que ha ido en aumento. Al examen se aprecia nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Otomastoiditis aguda
B) Laberintitis aguda
C) Vértigo postural paroxístico
D) Absceso cerebral
E) Neuronitis vestibular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Laberintitis aguda** (opción **B**). Cuadro clásico. Y las autítis no se acaban, seguimos ahora con autítis media crónica. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 153 6.03.1.022 · Otitis media crónica y com

Paciente de 45 años con otorrea crónica recurrente, hipoacusia conductiva y perforación timpánica central con colesteatoma evidenciado en TAC de oídos. ¿Cuál es el tratamiento?

A) Timpanomastoidectomía (cirugía)
B) Antibióticos tópicos indefinidos
C) Corticoides tópicos
D) Audífonos
E) Solo observar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Colesteatoma (otitis media crónica con colesteatoma): tratamiento quirúrgico obligatorio (timpanomastoidectomía) para erradicar el colesteatoma y prevenir complicaciones (mastoiditis, meningitis, parálisis facial).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 35 6.03.1.022 · Otitis media crónica y com

Niño de 8 años con otorrea crónica serosa, hipoacusia conductiva bilateral y tímpano con perforación central. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Gotas óticas de ciprofloxacino + taponamiento con algodón
B) Miringoplastia electiva
C) Timpanotomía de urgencia
D) Audiometría y derivación a otorrinolaringología
E) Antibiótico oral por 14 días

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Perforación timpánica crónica con hipoacusia conductiva: audiometría para evaluar pérdida auditiva y derivación a ORL para considerar timpanoplastía. No se tapona el oído perforado.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 84 6.03.1.022 · Otitis media crónica y com

Un paciente de 45 años, con historia de años de evolución de hipoacusia y supuración por oído derecho, consulta por compromiso del estado general, fiebre hasta 39ºC, vértigo y secreción ótica purulenta. Al examen se aprecia nistagmus horizontal con fase rápida a izquierda, a la otoscopía solo se aprecia secreción purulenta en conducto auditivo externo, no se observa tímpano. El tratamiento más adecuado en este caso es:

A) Antibióticos endovenosos
B) Lavado ótico
C) Cirugía de urgencia
D) Corticoides endovenosos
E) antiinflamatorios endovenosos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una laberintitis aguda. Se operan si son secundarias a un colesteatoma. Sin embargo, lo primero siempre es el tratamiento ATB ev, igual que en las mastoiditis. El nistagmo en las laberintitis va hacia la lesión en las etapas iniciales y escapa de la lesión en los casos más graves, cuando ya probablemente se perderá el oído (este es el caso). Es una pregunta muy muy discutible, pero yo marcaría el tratamiento antibiótico, por ser lo básico del tratamiento de la laberintitis aguda y porque la cirugía se evalúa caso a caso.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 146 6.03.1.001 · Alergia nasosinusal

Un paciente de 8 años de edad, con historia de un año de evolución de rinorrea mucopurulenta bilateral intermitente asociado a prurito y en algunas ocasiones a epistaxis, actualmente sin síntomas. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Antihistamínicos orales
B) Antibióticos orales
C) Corticoides tópicos
D) Derivar a cirugía de adenoides
E) Oximetazolina tópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Antihistamínicos orales** (opción **A**). Es una rinitis alérgica, sin obstrucción (los corticoides tópicos serían si hubiese obstrucción). Epistaxis anterior: más frecuente; área de Kiesselbach del tabique nasal; generalmente leve y responde al tratamiento inicial De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 111 6.03.1.001 · Alergia nasosinusal

Hombre joven con rinorrea serosa, congestión nasal y descarga posterior. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Corticoide intranasal
B) Descongestionantes tópicos nasales (oximetazolina)
C) Amoxicilina oral por 7 días
D) Solución salina hipertónica nasal
E) Antihistamínicos vía oral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Antihistamínicos vía oral** (opción **E**). Antihistamínicos vía oral. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 168 6.03.2.013 · Hematoma nasoseptal

Un paciente de 28 años presenta un pelotazo en la cara, hace 5 días, con golpe en la nariz. Evoluciona con dolor, edema, obstrucción nasal y luego sensación febril. Al examen físico se observa aumento de volumen bilateral, en relación al tabique nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Drenaje por punción con aguja fina
B) Drenaje quirúrgico con bisturí
C) Taponamiento anterior
D) Administrar analgésicos
E) Reducción en pabellón

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El hematoma del tabique nasal se debe drenar de inmediato, mediante incisión amplia con bisturí (también el hematoma del pabellón auricular). De lo contrario evoluciona con necrosis avascular del cartílago.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 171 6.03.2.013 · Hematoma nasoseptal

Un paciente de 34 años, sin antecedentes, sufre caída mientras subía una escalera, resultando con golpe en su rostro, al ingreso se en buenas condiciones generales, pero con epistaxis. Se realiza especuloscopía nasal donde se aprecia engrosamiento septal bilateral y epistaxis anterior. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Drenaje por punción
B) Observar y controlar en 2 semanas
C) Drenaje quirúrgico urgente
D) Antibióticos endovenosos
E) Taponamiento nasal bilateral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Drenaje quirúrgico urgente** (opción **C**). Es un hematoma del tabique. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 101 6.03.2.013 · Hematoma nasoseptal

Un paciente de 18 años sufre un pelotazo en la cara hace 7 días, evolucionando con dolor, obstrucción nasal, rinorrea purulenta y fiebre. Está subfebril y se aprecia aumento de volumen bilateral, en relación al septo nasal. En sus exámenes destaca leucocitosis de 15.000 blancos por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar drenaje con punción
B) Indicar antibióticos orales
C) Poner tapón, con gasas empapadas en antibióticos tópicos
D) Indicar corticoides y descongestionantes
E) Realizar drenaje inmediato con bisturí

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un hematoma septal bilateral. Debe drenarse en pabellón, de manera urgente, para evitar la necrosis del cartílago septal.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 118 6.03.2.013 · Hematoma nasoseptal

Adolescente con antecedente de trauma nasal hace 5-7 días, que consulta por fiebre y obstrucción nasal bilateral:

A) Hematoma septal
B) Absceso septal (confirmado por un ORL, Guevara se equivocó (también se equivoca guevara no olvidar))
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Absceso septal (confirmado por un ORL, Guevara se equivocó (también se equivoca guevara no olvidar))). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 160 6.03.1.019 · Otitis externa

Un niño de 6 años presenta prurito en el oído derecho desde hace 3 días, al que ayer se agregó otalgia intensa. Al examen Fsico, presenta dolor intenso a la compresión del trago y, en la otoscopía, se observa edema del conducto audi8vo y presencia de secreción amarillenta. El `mpano se observa sin perforación, de aspecto grisáceo. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Forunculosis del conducto audi2vo externo
B) O22s externa
C) O22s media aguda
D) Colesteatoma
E) Candidiasis del oído

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una oGGs externa clásica, de Gpo difuso, probablemente por Psdeudomonas aureginosa. Se trata con ciprofloxacino tópico. La otomicosis por cándida, Gene prurito generalmente con poco dolor y la secreción suele ser grumosa y blanquecina.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 170 6.03.1.019 · Otitis externa

Un niño de 9 años presenta otalgia de dos días de evolución, con secreción por el conducto auditivo, sin mal olor. Al examen físico se aprecia dolor a la tracción del pabellón auricular, con conducto auditivo estrecho, que dificulta la otoscopía, siendo imposible visualizar el tímpano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Otitis externa
B) Tapón de cerumen
C) Otitis media crónica
D) Cuerpo extraño ótico
E) Otitis media aguda perforada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El dolor al traccionar sugiere fuertemente una otitis externa. No suelen tener mal olor, ya que la pseudomona aureginosa no suele tenerlo. Además, el conducto estrecho es factor de riesgo para la otitis externa.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 102 6.03.1.019 · Otitis externa

Un niño de 7 años presenta otalgia derecha, asociada a otorrea. Al examinarlo presenta otorrea, sin olor y a la otoscopía presenta canal auditivo estrecho, por lo que no es posible ver el tímpano. Además presenta dolor al traccionar el pabellón auricular. EL diagnóstico más probable es:

A) Otitis media aguda
B) Otitis media crónica
C) Otitis externa
D) Tapón de cerumen
E) Otomastoiditis aguda

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Otitis externa** (opción **C**). Cuadro clásico (aunque pudieron haberlo descrito mejor).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 157 6.03.1.019 · Otitis externa

Un paciente de 35 años consulta por prurito en el oído izquierdo, asociado a secreción blanquecina y sensación de oído tapado. A la otoscopía se observa abundante secreción grumosa que cubre parcialmente el tímpano. ¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el manejo de este paciente?

A) Ciprofloxacino tópico
B) Fluconazol oral
C) Clotrimazol tópico
D) Amoxicilina oral
E) Ciprofloxacino oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Otomicosis: El cuadro clínico es característico de la otomicosis por Candida albicans, que se trata con antimicóticos tópicos como el clotrimazol.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 46 6.03.1.019 · Otitis externa

Un paciente de 35 años consulta por otalgia izquierda de 3 días de evolución, asociada a otorrea ipsilateral. El dolor aumenta al traccionar el pabellón auricular. A la otoscopía se observa el conducto auditivo externo edematoso, con escasa secreción y tímpano normal. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Amoxicilina oral
B) Ciprofloxacino tópico
C) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
D) Neomicina tópica
E) Antiinflamatorios orales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discutible, ya que tiene una otitis externa y tanto B como D son respuestas correctas y la evidencia así lo dice. La neomicina solo estaría contraindicada si hubiese perforación timpánica, ya que los aminoglicósidos son ototóxicos. Dejaremos la B como respuesta correcta solo porque a los otorrinos con los que conversamos les gusta más.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 167 6.03.1.019 · Otitis externa

Una paciente se pone un piercing en la oreja, sin embargo evoluciona con dolor y eritema, por lo que se la retira. Al sacar el piercing no ha mejorado y, en cambio, el pabellón auricular se observa eritematoso y aumentado de volumen, como se ve en la siguiente imagen (fuente:): ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pyogenes
B) Staphylococcus aureus
C) Streptococcus agalactiae
D) Staphylococcus epidirmidis
E) Pseudomona aureginosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Pseudomona aureginosa). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 113 6.03.1.019 · Otitis externa

Paciente con piercing en oreja; al retirarlo persiste aumento de volumen y eritema en la zona. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Staphylococcus aureus
C) Streptococcus pyogenes
D) Candida albicans
E) Mycobacterium fortuitum

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Pseudomonas aeruginosa). Pseudomonas aeruginosa. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 2 6.03.1.010 · Disfonías crónicas

Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuada para proseguir el estudio?

A) TAC de cuello
B) TAC de tórax
C) Ecografía de cuello
D) Nasofibrolaringoscopía
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Toda disfonía crónica se estudia con NFC. En este caso, además, el cuadro clínico sugiere cáncer de laringe, así que con mayor razón está indicada la NFC.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 103 6.03.1.010 · Disfonías crónicas

Un paciente de 30 años presenta disfonía persistente, de un mes de evolución, que inició al asistir a un concierto de Rock. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulos vocales
B) Disfonía musculotensional
C) Cáncer de laringe
D) Pólipos vocales
E) Reflujo faringo-laríngeo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los pólipos vocales se pueden producir de manera aguda, porque al forzar mucho la voz, se produce una hemorragia laríngea, que evoluciona a un pólipo. Los nódulos y la disfonía musculotensional suelen formarse por abuso vocal crónico. Nadie tiene cáncer de laringe a los 30 años

---

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 168 6.03.1.023 · Patología de glándulas sal

Un niño de 6 años es traído por su madre, dado que desde hace 2 horas comenzó con dolor y aumento de volumen en la zona paro`dea derecha. Al examen Fsico se palpa la glándula paró8da derecha aumentada de tamaño, dolorosa a la compresión. Al interrogatorio, la madre refiere que desde los 4 años ha presentado cuatro episodios similares, que han respondido al tratamiento con analgésicos. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de Sjögren
B) Paro2di2s viral recurrente
C) Li2asis del conducto de Stensen
D) Paro2di2s crónica
E) Tumor paroadeo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una sialoliGasis clásica. La obstrucción produce dolor y aumento de volumen súbitos. La desobstrucción puede ser intermitente. El tratamiento suele ser con analgésico y, si se ve el cálculo a la salida del conducto salival, es posible reGrarlo.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 71 6.03.1.023 · Patología de glándulas sal

Un paciente de 38 años con cuadro de 6 meses con aumento de volumen en región preauricular derecha. Al examen físico se constata nódulo en región preauricular de 4 cm de diámetro, de consistencia blanda, indoloro a la palpación y fija, sin afectación de la piel que lo recubre. El diagnóstico más probable:

A) Adenopatia tuberculosa
B) Adenoma pleomorfo
C) Lipoma
D) Quiste sebáceo
E) Sarcoma

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una mala pregunta, porque clínicamente es imposible distinguir un lipoma de un adenoma pleomorfo solo con la descripción del examen físico. Tiene las características clínicas de un lipoma (consistencia blanda, adherido en la zona profunda, pero sin compromiso de la piel). Sin embargo, la ubicación sugiere muy fuertemente un adenoma pleomorfo, que es el tumor benigno más frecuente de la parótida (50%, vs. 3% de los lipomas). El adenoma pleomorfo suele ser más móvil y no fijo y puede ser tanto duro, como blando, pero, aun así, dejaremos esa como respuesta correcta.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 178 6.03.1.023 · Patología de glándulas sal

Un paciente de 50 años consulta por aumento de volumen en la región masetérica izquierda, de crecimiento lento y consistencia dura. Al examen físico se palpa un tumor de 2 cm de diámetro, ubicado sobre la rama mandibular izquierda, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lipoma
B) Rabdomiosarcoma
C) Adenopatía preauricular
D) Tumor de parótida
E) Quiste sebáceo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tumor de Parótida: Un tumor ubicado en la zona descrita sugiere un tumor de parótida. Los tumores benignos son más frecuentes que los malignos. La parálisis facial y las adenopatías tumorales sugieren malignidad.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 143 6.03.1.026 · Rinorreas agudas

Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:

A) Amoxicilina oral
B) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
C) Corticoide tópico
D) Descongestionantes tópicos
E) Antihistamínicos orales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina. Los descongestionantes tópicos, no son muy indicados, ya que tienen efectos adversos y no solucionan los demás síntomas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 66 6.03.1.026 · Rinorreas agudas

Un niño de 5 años consulta por un cuadro de 7 días de evolución de rinorrea purulenta, descarga posterior, cefalea, fiebre y obstrucción nasal. En el último tiempo se agrega mayor fiebre, más edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Queratoconjuntivitis viral
B) Absceso periorbitario
C) Conjuntivitis bacteriana
D) Sinusitis maxilar
E) Absceso frontal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
[Pregunta disputada] Es una mala pregunta. En estricto rigor parece una celulitis preorbitaria, que no estaba en las opciones, secundaria a una sinusitis (no queda claro si es maxilar, etmoidal o frontal). Tampoco parace un absceso orbitario (no existe el concepto periorbitario), por no tener limitación a la movilización de los movimientos, proptosis o otras alteraciones similares.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 139 6.03.1.026 · Rinorreas agudas

Un paciente de 17 años consulta por un cuadro que inició hace 12 días, consistente en congestión nasal, rinorrea mucosa abundante y odinofagia. En los últimos días la rinorrea se vuelve purulenta y empeoran los síntomas, agregándose sensación febril y tos seca mayor en las noches. En el examen físico se constata fiebre de 38,2°C, FC: 78x', FR: 12x', se observa faringe eritematosa, con descarga posterior y se observa rinorrea purulenta en ambas fosas nasales. Su examen cardiopulmonar es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amoxilicilina oral por 7 días
B) Claritromicina oral por 10 días
C) Aseo con suero fisiológico
D) Corticoides orales por 7 días
E) Antihistamínicos orales por 7 días

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Amoxilicilina oral por 7 días** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 118 6.03.1.026 · Rinorreas agudas

Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre, cefalea, rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y obstrucción nasal. Desde hace poco se agrega mayor fiebre, además de edema y eritema periocular derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Absceso frontal
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Sinusitis maxilar
D) Absceso periorbitario
E) Conjuntivitis viral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Absceso periorbitario** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 13 6.03.1.026 · Rinorreas agudas

Niño con rinorrea purulenta que desarrolla fiebre y aumento de volumen palpebral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Celulitis preseptal
B) Dacriocistitis aguda
C) Conjuntivitis bacteriana
D) Absceso periorbitario
E) Sinusitis etmoidal sin complicación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Absceso periorbitario** (opción **D**). Absceso periorbitario. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 94 6.03.2.009 · Cuerpo extraño en vía aére

Un paciente de 26 años, con antecedente de daño cerebral severo, desde hace 2 días presenta sialorrea, tos áfona, estridor inspiratorio y reticencia a alimentarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neumonía aspirativa
B) Epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo B
C) Crisis epiléptica focal
D) Cuerpo extraño laríngeo
E) Cuerpo extraño esofágico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
E? Por la tos áfona y el estridor es un cuerpo extraño laríngeo, pero por la sialorrea y la reticencia a comer era esofágico. Esta pregunta inducía a error. Yo marqué laríngeo, porque le di más importancia a los síntomas laríngeos.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 117 6.03.1.030 · Sinusopatías crónicas

Una paciente con un cuadro de 5 años de evolución de marcada obstrucción nasal y rinorrea acuosa. Se realiza una radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de los senos maxilares. Se solicita un TAC de cavidades paranasales que muestra engrosamiento de la mucosa de los senos etmoidales y maxilares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar fluticasona tópica
B) Realizar cirugía endoscópica nasal
C) Solicitar rinomanometría
D) Indicar tratamiento antibiótico
E) Iniciar antihistamínicos orales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parecía una rinitis crónica, con predominio de síntomas obstructivos, por lo que de primera línea se deben indicar corticoides tópicos.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 69 · 6.03.1.030 · Sinusopatías crónicas

Una paciente de 43 años presenta obstrucción nasal marcada, asociada a rinorrea de 5 años de evolución, con sensación de presión facial, cefalea e hiposmia. Se solicita radiografía de cavidades paranasales, que muestra velamiento de ambos senos maxilares. La TAC de cavidades paranasales muestra secreciones e inflamación de la mucosa de ambos senos maxilares y de celdillas etmoidales bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Fluticasona nasal
B) Azitromicina
C) Cirugía endoscópica nasal
D) Rinomanometría
E) Resonancia magnética nuclear de cavidades paranasales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una sinusitis crónica. Si bien también hay que agregarle antibióticos, la azitromicina no sirve, sino amoxicilina más ácido clavulánico. Además, el hecho que sea bilateral y que afecte todos los senos paranasales obliga a descartar la rinitis alérgica como la causa más frecuente. Por tanto, sin duda, la respuesta es fluticasona tópica.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 58 · 6.03.1.024 · Poliposis nasal

Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. Respira por la boca, por la obstrucción nasal. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante, que obstruyen completamente las fosas nasales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar fluticasona tópica c/12 horas
B) Iniciar prednisona oral 1 mg/Kg/día por 7 días
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Realizar cirugía endoscópica nasal
E) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El tratamiento de los pólipos nasales es con corticoides orales. Si solo hubiese tenido la rinitis alérgica, con obstrucción, pero sin pólipos, el tratamiento serían los corticoides tópicos.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 118 · 6.03.1.024 · Poliposis nasal

Un paciente, con antecedente de rinitis alérgica, presenta marcada obstrucción nasal marcada, asociada varios episodios de sinusitis en el último tiempo. En la rinoscopía anterior, se visualizan numerosos pólipos en la mucosa, de aspecto pálido y brillante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar fluticasona tópica
B) Iniciar prednisona oral
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Realizar cirugía endoscópica nasal
E) Solicitar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar prednisona oral** (opción **B**). La poliposis nasal se trata con corticoides orales.. Tratamiento inicial: corticoides orales porque el spray no llega por la obstrucción; luego corticoides intranasales permanentes De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 170 · 6.03.2.002 · Absceso periamigdalino

Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que y en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abomba- miento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Absceso retrofaríngeo
B) Angina de Ludwig
C) Amigdalitis ulcero-necrótica
D) Absceso periamigdalino
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Absceso periamigdalino** (opción **D**). Es un absceso periamigdalino clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 119 · 6.03.2.002 · Absceso periamigdalino

Un paciente está en el tercer día de tratamiento con azitromicina, por una amigdalitis con exudado. Consulta por aumento de la odinofagia, asociada a imposibilidad de comer por trismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Absceso periamigdalino
B) Angina de Ludwig
C) Mononucleosis infecciosa
D) Absceso parafaríngeo
E) Absceso retrofaríngeo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Absceso periamigdalino** (opción **A**). Es un absceso periamigdalino clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 48 · 6.03.2.002 · Absceso periamigdalino

Hombre de 20 años con odinofagia severa, fiebre 39°C, dificultad para abrir la boca (trismus) y desviación de la úvula hacia el lado contrario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Angina de Ludwig
B) Faringitis estreptocócica
C) Absceso periamigdalino
D) Mononucleosis infecciosa
E) Epiglotitis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Absceso periamigdalino: trismus + desviación uvular contralateral + odinofagia severa + voz gangosa = tríada clásica. Complicación de faringoamigdalitis bacteriana. Tratamiento: punción-drenaje + ATB (penicilina + metronidazol o amoxicilina-clavulánico) + analgesia.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 148 · 6.03.2.002 · Absceso periamigdalino

Paciente con contractura de músculos masticatorios con úvula desplazada. rigidez de nuca esbozada, dolor cervical, gran exudado de amígdalas bilaterales:

A) Absceso retrofaringeo
B) Flegmon periamigdalina
C) Absceso peritonsila
D) Absceso retrotonsilar
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Absceso peritonsila). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Absceso retrofaringeo, Flegmon periamigdalina) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 154 · 6.03.1.029 · Síndrome vertiginoso

Paciente de 50 años con episodios de vértigo rotatorio, tinnitus unilateral fluctuante e hipoacusia neurosensorial ipsilateral. Los síntomas duran horas. Audiometría disponible en una semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Ménière
B) Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)
C) Neuritis vestibular
D) ACV de fosa posterior
E) Schwannoma vestibular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tríada de Ménière: vértigo episódico + hipoacusia neurosensorial fluctuante + tinnitus, todo ipsilateral, episodios de horas = enfermedad de Ménière. El VPPB dura segundos y no tiene hipoacusia.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 137 · 6.03.1.029 · Síndrome vertiginoso

Paciente con vértigo posicional y maniobra de Dix-Hallpike positiva para canal posterior izquierdo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Betahistina oral por 4 semanas
B) Dimenhidrinato oral por 7 días
C) Maniobras de reposición canalicular (Epley)
D) Derivar a neurología urgente
E) Prednisona oral 1 mg/kg/día

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Maniobras de reposición canalicular (Epley)** (opción **C**). Maniobras de reposición canalicular (Epley). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 7 · 6.03.1.029 · Síndrome vertiginoso

Un paciente presenta vértigo, de segundos de duración, que se le produce al girar la cabeza a derecha, mientras está acostado. No tiene síntomas auditivos y como antece- dente refiere haber sufrido un traumatismo encefálico hace 10 días, en un accidente de trabajo. No presenta adiadococinesia ni dismetría. El resto de su examen físico es nor- mal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar flunarizina
B) Iniciar tietilperazina
C) Solicitar un TAC de oídos
D) Derivar para maniobras de reposición vestibular
E) Iniciar difenidol

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Derivar para maniobras de reposición vestibular** (opción **D**). Es un vértigo postural paroxístico benigno clásico.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 168 · 6.03.1.029 · Síndrome vertiginoso

Un paciente de 35 años presenta un golpe en la cabeza, debido a una caída a nivel, hace un mes. Desde entonces ha presentado reiterados episodios de vértigo intenso, de segundos de duración, que aparece con algunos movimientos de la cabeza. No tiene síntomas auditivos y su examen neurológico muestra movilidad coordinada y conservada, sin alteraciones de la marcha ni del examen de pares craneanos. Los síntomas se reproducen con las maniobras de Dix-Hallpike. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Difenidol 25 mg al día por 7 días
B) Betahistina 8 mg cada 12 horas por 1 mes
C) Solicitar prueba calórica
D) Solicitar resonancia magnética nuclear de troncoencéfalo y cerebro
E) Realizar maniobras de reposición vestibular

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar maniobras de reposición vestibular** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 141 · 6.03.1.028 · Síndrome respirador bucal

Un niño de 6 años consulta por epistaxis bilateral frecuent

E) Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:
A) Rinofibroangioma bilateral
B) Rinitis alérgica
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Hipertrofia de adenoides

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Además, tiene antecedente de ser respirador bucal, roncar en la noche y presentar infecciones respiratorias altas a repetición. El diagnóstico más probable es:). El respirador bucal es un motivo de consulta frecuente en pediatría y otorrinolaringología. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 48 · 6.03.1.028 · Síndrome respirador bucal

Un niño de 7 años, respirador bucal es traído por su madre. No presenta apnea del sueño, ni infecciones a repetición. Al examen físico, no tiene obstrucción nasal y se ob- serva faringe con amígdalas grado II. Se solicita radiografía de cavum, que constata hi- pertrofia adenoidea, con 80% de obstrucción. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Desloratadina oral
B) Fluticasona intranasal
C) Adenoidectomía
D) Observar evolución y controlar ambulatoriamente
E) Solicitar TAC de cavidades paranasales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

D? Esta pregunta excede lo que debe saber un médico general y causa conflicto en los mismo ORL que la analizaron. Tiene adenoides grado III, por lo que hay una indica- ción relativa de cirugía, pero no tiene complicaciones y a su edad ya no seguirán cre- ciendo, por lo que probablemente se pueda intentar el tratamiento con corticoides tópi- cos (han demostrado reducir el tamaño de los adenoides) o incluso observar evolución, ya que la respiración bucal, no es de tipo obstructivo, sino por otra causa (hiperlaxitud, malos hábitos).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 7 · 6.03.1.005 · Cáncer laríngeo e hipofarí

Un paciente de 66 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por otalgia derecha, de algunos meses de evolución, asociado a odinofagia y disfagia, a lo que se le ha agregado atoramiento con algunos alimentos y cambios en la resonancia de la voz. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer de esófago
B) Disfunción temporomandibular
C) Cáncer de hipofaringe
D) Faringitis crónica
E) Cáncer de laringe

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un clásico cáncer de hipofaringe. El cáncer de laringe suele presentar disfonía progresiva, sin los otros síntomas. El cáncer de esófago presenta disfagia lógica, sin los otros síntomas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 58 · 6.03.1.005 · Cáncer laríngeo e hipofarí

Un paciente de 61 años, fumador, consulta por disfonía de 2 meses de evolución, asociada a aparición de una adenopatía cervical, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen inicial para el estudio de este paciente?

A) Radiografías de cuello
B) Endoscopía digestiva alta
C) Nasofibroscopía
D) Ecografía de cuello
E) TAC de cuello

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La disfonía crónica se estudia con nasofibroscopía (más aún cuando se sospecha un cáncer de laringe, como en este caso).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 67 · 6.03.1.005 · Cáncer laríngeo e hipofarí

Un paciente de 58 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disfonía de 3 semanas de evolución, asociada a ligera odinofagia. Al examen físico, además, se palpa una adenopatía submandibular, de consistencia aumentada. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) TAC de cuello
B) TAC de tórax
C) Ecografía de cuello
D) Nasofibrolaringoscopía
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Nasofibrolaringoscopía). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (TAC de cuello, TAC de tórax) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 79 · 6.03.1.025 · Rinorrea crónica

Un paciente de 80 años consulta por rinorrea bilateral, de tres meses de evolución, muy molesta, asociada a congestión nasal, que es más intensa en las mañanas y aumenta con los cambios de temperatura. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer nasal
B) Pólipos nasales
C) Sinusitis bacteriana crónica
D) Rinitis vasomotora
E) Rinitis alérgica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene clínica de rinitis. Por ser más intensa en las mañanas y con los cambios de temperatura, es de tipo vasomotora. Otras cosas clásicas de la rinitis vasomotora es que empeora con el estrés, con alimentos muy calientes o condimentados. El cáncer se presenta como obstrucción y rinorrea serosanguinolenta unilateral. Los pólipos se ven en pacientes jóvenes y suelen ser bilaterales, con marcada obstrucción y sí pueden tener rinorrea o sinusitis secundarias.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 108 · 6.03.1.033 · Trastornos de habla y leng

Un niño de 4 años presenta escaso vocabulario para su edad y confunde muchas palabras. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el estudio de este paciente?

A) Evaluación fonoaudiológica
B) Potenciales evocados auditivos
C) Emisiones otoacústicas
D) Audiometría
E) Control en 6 meses

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil y discutible, pero se resumen en "¿Cuál es el examen de elección ante la sospecha de hipoacusia congénita?" y la respuesta es potenciales evocados auditivos. Las emisiones otoacústicas son una opción más barata, como screening en los pacientes asintomáticos, pero si hay una sospecha, lo ideal es pedir potenciales evocados. Eso sí, a los 4 años es posible que el paciente ya coopere en la audiometría, por lo que técnicamente es una mala pregunta.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 63 6.03.1.033 · Trastornos de habla y leng

Un lactante de 6 meses, alimentado con lactancia materna exclusiva, con buen aumento de peso y sin antecedentes de importancia, acude a control de niño sano. En su examen Fsico únicamente llama la atención que su úvula 8ene una muesca central, que la divide parcialmente en dos, sin otras alteraciones. ¿Qué patología o malformación debe ser buscada de manera dirigida ante este hallazgo?

A) Membrana laríngea subgló2ca
B) Hemangiomas supragló2cos
C) Fisura pala2na submucosa
D) Atresia de coanas
E) Parálisis laríngea

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Membrana laríngea subglótica: estridor y llanto débil desde el período neonatal. Hemangiomas supraglóticos: estridor progresivo en lactante de 1–3 meses, que empeora al llorar o alimentarse y puede asociarse a hemangiomas cutáneos “en barba”. Fisura palaGna submucosa: úvula bífida + voz hipernasal + regurgitación nasal, pese a paladar aparentemente normal. Atresia de coanas: recién nacido con cianosis que mejora al llorar (respira por la boca) y empeora al alimentarse; si es bilateral es una urgencia neonatal. Parálisis laríngea: estridor con disfonía, voz bitonal o llanto débil; la bilateral puede causar insuficiencia respiratoria.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 31 6.03.1.015 · Masa cervical

Una paciente de 35 años, que cursa una infección respiratoria alta, presenta aparición de aumento de volumen cervical progresivo, de localización suprahioidea. A la palpación, se constata consistencia gomosa y se observa que asciende al solicitarle a la paciente que protruya la lengua. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Nódulo 2roideo
B) Quiste dermoide
C) Adenopaaa cervical
D) Quiste del conducto 2rogloso
E) Linfoma

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un quiste del conducto Grogloso clásico. La ubicación en la línea media, suprahioidea es lo más característico.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 75 6.03.1.015 · Masa cervical

Un paciente de 23 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que ha aumentado lentamente de tamaño en los últimos meses. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, en la línea media, ubicado entre el mentón y el cartílago tiroides, de 3 cm de diámetro y consistencia blanda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste branquial
B) Adenitis supurada
C) Quiste del conducto tirogloso
D) Adenoma de glándula salival submandubilar
E) Quiste epidermoide

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Adenoma de glándula salival submandubilar** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 111 6.03.1.015 · Masa cervical

Un paciente de 17 años, presenta aumento de volumen submentoniano, de 5 años de evolución. Hace 2 días aumenta de tamaño y se vuelve doloroso. Al examen físico, tiene aumento de volumen y eritema en la zona, con dolor importante a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Linfoma
B) Adenitis submandibular
C) Sialoadenitis bacteriana
D) Quiste del conducto tirogloso infectado
E) Sialolitiasis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
De las opciones, el quiste del conducto tirogloso es la única que tiene ubicación en la línea media (aunque con esa redacción no queda claro si la localización submentoniana es central o lateral) y que, además, tiene ese perfil temporal (5 años, que ahora se complicó).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 92 6.03.1.015 · Masa cervical

Un paciente de 18 años consulta por odinofagia intensa de 2 días de evolución asociada a fiebre hasta 38,5 °C, a lo que en las úl8mas horas se agregó aumento de volumen doloroso en la zona submandibular derecha. Al examen Fsico se aprecia faringe conges8va con aumento de volumen amigdalino mayor a derecha, con exudado purulento en su superficie. Además, se palpa un aumento de volumen de consistencia blanda y dolorosa, con eritema en su superficie, de 4 cm de diámetro, en relación con la zona submandibular derecha. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Absceso periamigdalino
B) Mononucleosis infecciosa
C) Quiste branquial infectado
D) Adeni2s supurada
E) Linfoma de Hodgkin

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una amigdaliGs bacteriana complicada con una adeniGs supurada (aumento de volumen submandibular). El absceso periamigdalino se caracteriza por dolor muy intenso, con trismus (imposibilidad de abrir bien la boca) y abombamiento del pilar amigdalino.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 88 6.03.2.017 · Síndrome vertiginoso agudo

Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas auditivos. El diagnóstico más probable es:

A) Parálisis cocleovestibular
B) Vértigo postural
C) Hídrops endolinfático
D) Neuronitis vestibular
E) Neurinoma del acústico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una neuronitis vestibular clásica. La ausencia de síntomas auditivos descarta la parálisis cócleovestibular (que es una sordera súbita: cócleo + una neuronitis vestibular: vestibular) y el hídrops endolinfático (o enfermedad de Ménière). El vértigo postural se desencadena con movimientos de la cabeza.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 101 6.03.2.017 · Síndrome vertiginoso agudo

Una paciente de 32 años presenta vértigo intenso de 2 días de evolución, el que dificulta la marcha y se asocia a vómitos en múltiples oportunidades. Al examen físico se encuentra audición conservada y se objetiva un nistagmo unidireccional horizontal a derecha y lateropulsiones a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vértigo postural paroxístico benigno
B) Migraña vertebrobasilar
C) Parálisis vestibular periférica
D) Accidente vascular encefálico de fosa posterior
E) Enfermedad de Ménière

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Vértigo Periférico: El caso describe un vértigo con características de vértigo periférico sin signos de alarma. La intensidad y duración de los síntomas sugieren una parálisis vestibular periférica o neuronitis vestibular. La enfermedad de Meniere presentaría síntomas auditivos. El vértigo postural paroxístico benigno suele durar solo unos segundos y se desencadena con los movimientos de la cabeza.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 44 6.03.2.016 · Perforación timpánica trau

Una mujer de 32 años, consulta por dolor intenso en el oído izquierdo, que inició después de haberse limpiado con un cotonito (hisopo). No tiene síntomas vestibulares, aunque refiere hipoacusia moderada en dicho oído. Se realiza otoscopía, que muestra presencia de una perforación timpática triangular, con sangre en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Lavado de oídos
B) Ciprofloxacino tópico
C) Derivar a timpanoplastía
D) Control en un mes
E) TAC de oídos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Lavado de oídos** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Ciprofloxacino tópico, Derivar a timpanoplastía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 138 6.03.2.016 · Perforación timpánica trau

Paciente usuaria de cotonito con perforación timpánica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control en un mes (resolución espontánea)
B) Tapón de algodón y antibiótico tópico ótico
C) Miringoplastia inmediata
D) TAC de hueso temporal
E) Derivar a ORL urgente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Control en un mes (resolución espontánea)** (opción **A**). Control en un mes (resolución espontánea). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 110 6.03.2.018 · Sordera súbita

Un hombre de 33 años, sin antecedentes de importancia, despierta con hipoacusia del oído izquierdo, asociado a tinitus, sin otros síntomas. No ha presentado vértigo y su otoscopía no muestra alteraciones. Su examen neurológico no aporta nueva información. ¿Cuál es el examen inicial para evaluar a este paciente?

A) Impedanciometría
B) TAC de oído
C) TAC de cerebro
D) Prueba calórica
E) Audiometría

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Audiometría). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Impedanciometría, TAC de oído) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 123 6.03.2.018 · Sordera súbita

Paciente de 45 años con pérdida súbita de audición unilateral de 48 horas de evolución, sin vértigo ni acúfenos. Audiometría: hipoacusia neurosensorial unilateral de 50 dB. ¿Cuál es el tratamiento?

A) Corticoides orales (prednisona 1 mg/kg/día x 10 días)
B) Antibióticos orales
C) Antivirales (aciclovir)
D) Solo observar, resolución espontánea
E) Cirugía descompresiva del nervio auditivo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hipoacusia súbita neurosensorial: tratamiento estándar = corticoides orales en alta dosis (prednisona 1 mg/kg/día) iniciados dentro de las primeras 72h. Mejoran pronóstico en ~50% de los casos.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 136 6.03.4.006 · Audiometría básica

Paciente con hipoacusia y tinnitus, examen otoneurológico normal. ¿Cuál es el examen a solicitar?

A) Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral
B) Impedanciometría
C) RNM de ángulo pontocerebeloso
D) TAC de peñascos
E) Audiometría

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Audiometría). Audiometría. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Potenciales evocados auditivos del tronco cer, Impedanciometría) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 54 6.03.4.006 · Audiometría básica

Mujer que comienza con hipoacusia y tinnitus. ¿Cual es el examen inicial? (Repetida años anteriores)

A) Impedanciometría
B) Audiometría,
C) Hemograma y VHS
D) Ecografía
E) Radiografía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Audiometría,). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Impedanciometría, Hemograma y VHS) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 86 6.03.1.013 · Estridor laríngeo

Lactante con estridor desde nacimiento causa a. Laringomalacia

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Control sano habitual). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 92 6.03.1.014 · Hipoacusia neonatal

Lactante que llega sin test de audición a primer control:

A) Emisiones otoacústicas
B) Impedanciometría
C) Evaluación por fono
D) Audiometría
E) Reflejo cocleopalpebral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Emisiones otoacústicas). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Impedanciometría, Evaluación por fono) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 128 6.03.1.020 · Otitis media aguda

Niño con antecedente de resfrío de 1 semana que inicia con otorrea y otalgia, a la otoscopia secreción purulenta, no se visualiza tímpano:

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina/ Ac. clavulánico
C) Ciprofloxacino tópico
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Amoxicilina). La otitis media aguda es una infección bacteriana del oído medio muy frecuente en niños y menos frecuente en adultos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 35 6.03.1.007 · Diagnóstico diferencial de

Una paciente de 48 años consulta por hipoacusia bilateral de 10 años de evolución, progresiva, que aumentó especialmente durante su último embarazo. Su otoscopía es normal y el examen neurológico no muestra alteraciones vestibulares ni cerebelosas. Se realiza test de diapasones, que muestra prueba de Rinne negativo bilateral y prueba de Weber que no lateraliza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipoacusia genética neurosensorial
B) Ototoxicidad
C) Otoesclerosis
D) Hipoacusia hormonal
E) Otitis media con efusión

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Otoesclerosis: La prueba de Rinne es positiva en hipoacusias sensorioneurales y negativa en hipoacusias de conducción, como en este caso. La prueba de Weber lateraliza al lado afectado en la hipoacusia de conducción y al lado sano en la sensorioneural; pero si la hipoacusia es bilateral y simétrica, no lateraliza. La otoesclerosis y la otitis media con efusión son hipoacusias de conducción, pero el curso crónico por 10 años y el empeoramiento durante el embarazo son característicos de la otoesclerosis. Esta última es la causa más común de hipoacusia de conducción con tímpano normal, a diferencia de la otitis media crónica que presenta alteraciones timpánicas. Las hipoacusias sensorioneurales, en cambio, tienen tímpano sano en la otoscopía.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 90 6.03.2.006 · Barotrauma ótico y trauma

Una paciente de 33 años, consulta por otalgia y sensación de oído tapado, mayor a derecha. Refiere que el día anterior estuvo nadando, sumergiéndose a 1,5 metros de profundidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Otitis media aguda
B) Otitis media con efusión
C) Perforación timpánica
D) Otitis externa
E) Barotrauma

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Barotrauma: El caso describe un barotrauma típico, que se presenta en situaciones con cambios de presión atmosférica, como el buceo, viajes en avión, cambios bruscos de altitud, etc.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 149 6.03.5.015 · Traqueostomía y cricoidost

Una paciente de 47 años con antecedente de neumonía severa por SARS-CoV-2 que requirió intubación y ventilación mecánica por 10 días, evoluciona con dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico presenta estridor bifásico, taquicardia a 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria aumentada a 20 respiraciones por minuto y un TAC de cuello que muestra estenosis marcada de la vía aérea a nivel subglótico. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo actual?

A) Intubación orotraqueal
B) Cricotirotomía
C) Traqueostomía
D) Oxigenoterapia por mascarilla de no recirculación
E) Broncoscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Estenosis Subglótica: La estenosis subglótica post-intubación se trata con dilatación con balón mediante broncoscopia en casos estables. Si el paciente está descompensado, como en este caso, se requiere una traqueotomía de urgencia para asegurar la vía aérea. La intubación puede ser difícil por la estenosis severa, y la cricotirotomía es riesgosa porque no se sabe si se realizará por encima o por debajo de la estenosis. Es una pregunta muy discutible y es posible que el Eunacom haya considerado correcta otra opción.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 23 6.03.4.002 · Radiografía de cavum

Un niño de 5 años presenta infecciones respiratorias a repe8ción, asociadas a rinorrea bilateral frecuente y obstrucción nasal con respiración bucal habitual. La madre relata roncopa`a y dificultades para dormir. Además, recientemente ha presentado dos episodios recientes de o88s media aguda que respondieron a amoxicilina. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Radiogra:a de cavum
B) TAC de cavidades paranasales
C) fíasofibroscopía
D) Polisomnogra:a
E) Niveles plasmá2cos de IgE específica contra alérgenos respiratorios

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una hipertrofia de adenoides. Aunque la nasofibroscopía es el mejor examen (y se hará de segunda línea), el inicial es la radiografía de cavum, que es barato y menos molesto para el niño.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 149 6.03.1.009 · Disfonías agudas

Una paciente de 27 años sufre atoro con un pedazo de alimento hace 7 días, que obstruyó la vía aérea y requirió maniobra de Heimlich para su desobstrucción. Desde entonces ha persis8do con disfonía y carraspera. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar endoscopía diges2va alta
B) Solicitar radiogra:as de cuello
C) Solicitar TAC de cuello
D) Solicitar nasofibrolaringoscopía
E) Solicitar videodeglución

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Todas disfonía persistente se evalúa con nasofibrolaringoscopía (NFL). Además, el antecedente de cuerpo extraño y maniobra de Heimlich hacen sospechar una lesión laríngea o de las cuerdas vocales, parálisis cordal o cuerpo extraño residual, que se objetivarían con la NFL.

OFTALMOLOGÍA

Módulo 2: Cirugía y Especialidades · Colección Tomo 15

57 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

25 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.02.1.001	Ametropía	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 15 · 15.15 (Pág. 50)
6.02.1.002	Blefaritis	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 15 · 15.3 (Pág. 11)
6.02.1.003	Catarata	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 15 · 15.10 (Pág. 33)
6.02.1.005	Conjuntivitis bacteriana aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 15 · 15.2 (Pág. 9)
6.02.1.006	Conjuntivitis bacteriana crónica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · 15.4 (Pág. 13)
6.02.1.009	Dacriocistitis aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.010	Degeneración macular relacionada a la edad	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.011	Estrabismo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · C.23 (Pág. 50)
6.02.1.012	Glaucoma congénito	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 15 · C.24 (Pág. 52)
6.02.1.013	Glaucoma crónico	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.016	Neuritis óptica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.017	Neuropatía óptica isquémica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.018	Obstrucción completa de la vía lacrimal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.021	Queratitis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 15 · 15.5 (Pág. 15)
6.02.1.024	Síndrome de ojo seco	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · C.16 (Pág. 36)
6.02.1.028	Tumores de párpado	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.029	Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.030	Uveítis anterior o posterior	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 15 · 15.17 (Pág. 56)
6.02.2.001	Causticaciones oculares	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.003	Desprendimiento de retina	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.005	Glaucoma agudo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.006	Hemorragia vítrea	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.02.2.007	Herida penetrante o perforante ocular	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.010	Úlcera corneal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.5.005	Eversión palpebral	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 44 6.02.1.005 · Conjuntivitis bacteriana a

Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de cloranfenicol cada 8 horas, sin embargo evoluciona posteriormente con aumento del enrojecimiento, edema palpebral y quemosis. El diagnóstico más probable es:

A) Alergia al cloranfenicol
B) Celulitis orbitaria
C) Obstrucción lacrimal
D) Chalazion
E) Absceso tarsal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una conjuntivitis bacteriana, que se complicó con una celulitis orbitaria o postseptal (por la quemosis). La alergia al CAF suele presentarse de otra forma y es muy rara.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 91 6.02.5.005 · Eversión palpebral

Un paciente de 50 años, sin antecedentes, consulta por ojo rojo izquierdo desde ayer asociado a sensación de dolor, blefarospasmo y fotofobia. Su examen físico es dificultoso por dolor, por lo que se administra anestésico local, tras lo cual se aprecia ojo rojo tipo central y al aplicar fluoresceína se tiñe la mitad superior de la córnea. La conducta más apropiada en este caso es:

A) Evertir el párpado superior
B) Aplicar colirio de gentamicina
C) Poner parche ocular y controlar
D) Aplicar colirio con atropina
E) Realizar aseo local

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Evertir el párpado superior** (opción **A**). Tiene una erosión corneal por un cuerpo extraño tarsal. Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 3 6.02.2.005 · Glaucoma agudo

Un paciente de 30 años, hipermétrope, consulta por cefalea intensa, en el lado derecho, asociado a náuseas, de intensidad 10/10. Al examen físico se observa ojo rojo profundo en el lado derecho, con pupila en midriasis fija y arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma agudo
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Cefalea cluster
D) Celulitis orbitaria
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Glaucoma agudo** (opción **A**). Es un glaucoma agudo clásico.. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 149 6.02.2.005 · Glaucoma agudo

Un paciente de 48 años, con antecedente de hipermetropía, consulta por dolor en el ojo izquierdo, muy intenso, irradiado a la frente. Al examen físico, se aprecia eritema periquerático del ojo izquierdo, con pupila midriática arreactiva y se aprecia opacidad corneal. El ojo derecho tiene visión 20/20, mientras que el ojo izquierdo tiene visión borrosa, que solo es capaz de contar dedos. El diagnóstico más probable es:

A) Conjuntivitis
B) Uveítis aguda
C) Queratitis viral aguda
D) Trombosis de la vena central de la retina
E) Glaucoma agudo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Glaucoma agudo** (opción **E**). Es un glaucoma agudo clásico: antecedente de hipermetropía, ojo rojo central y midriasis arreactiva.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 144 6.02.2.005 · Glaucoma agudo

Una paciente de 50 años consulta por dolor ocular izquierdo de inicio agudo, asociado a visión borrosa. Al examen físico destaca ojo rojo periquerático y pupila midriáticas arreactivas, la agudeza visual es de 0,6 en ojo izquierdo y 1 en ojo derecho. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Uveítis aguda
B) Endoftalmitis
C) Queratitis aguda
D) Escleritis
E) Glaucoma agudo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Glaucoma agudo** (opción **E**). Glaucoma agudo de libro. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 80 6.02.2.005 · Glaucoma agudo

Una paciente de 54 años, con antecedente de jaqueca, que trata profilácticamente con topiramato. Refiere estar con más estrés del habitual. Hace dos horas comienza con cefalea intensa, de localización periocular derecha, asociada a náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia el ojo izquierdo enrojecido, con la pupila fija, en semimidriasis. La conducta inicial más adecuada es:

A) Manitol endovenoso
B) Clorpromazina endovenosa
C) Ketorolaco endovenoso
D) Oxígeno al 100% más eletriptán subcutáneo
E) Carbamazepina oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un glaucoma agudo clásico, cuyo tratamiento incluye el manitol ev, gotas mióticas (ej. pilocarpina) y la iridotomía láser.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 150 · 6.02.1.010 · Degeneración macular relac

Un paciente de 77 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, presenta visión distorsionada de las letras y refiere que las líneas se ven onduladas. Actualmente tiene un escotoma central. Se hace un fondo de ojo, que se muestra a continuación: Foto 14 (https://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/01/25/medicina/1169733276.html). El diagnóstico más probable es:

A) Desprendimiento de retina
B) Retinopatía hipertensiva
C) Trombosis de la vena central de la retina
D) Catarata
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un DMRE clásica, tanto por la clínica (metamorfopsias y escotoma central), como por el fondo de ojo (aunque se veían exudados y hemorragias maculares y no solo drusas).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 105 · 6.02.1.010 · Degeneración macular relac

Un paciente de 80 años, diabético, hipertenso y fumador de 30 paquetes-año, consulta por dificultades para leer, que ha empeorado lentamente. Además notó hace poco una metamorfopsia en el ojo izquierdo. Tiene agudeza visual de 0,8 en el ojo derecho y de 0,4 en el ojo izquierdo y al examen ocular, se aprecia leve disminución del rojo pupilar bilateral, con reflejos fotomotores normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Glaucoma de ángulo abierto
C) Desprendimiento de retina
D) Glaucoma de ángulo estrecho
E) Retinopatía diabética

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Degeneración macular relacionada con la edad** (opción **A**). La metamorfopsia, la edad y el cuadro lento, sin más información es lo característico de la DMRE. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 171 · 6.02.1.010 · Degeneración macular relac

Un paciente de 72 años consulta por dificultades en la lectura, que han empeorado en el último mes, a pesar de que realizó un cambio de lentes hace 6 meses. No presenta otros síntomas, tiene agudeza visual 20/80 en el ojo derecho y 20/40 en el ojo izquierdo y refiere que ve algunos objetos deformados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Glaucoma crónico
C) Cataratas
D) Desprendimiento de retina
E) Edema macular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La disminución de la agudeza visual puede ser tanto por cataratas como por DMRE, pero la deformación de los objetos (metamorfopsias) sugiere mucho una DMRE. El glaucoma no afecta la agudeza visual (al final, sí), sino el campo visual.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 99 · 6.02.1.010 · Degeneración macular relac

Paciente hipertenso con dificultad para la lectura y visión deformada de objetos pese a lentes recientes. ¿Diagnóstico más probable?

A) Retinopatía hipertensiva
B) Oclusión de vena central de la retina
C) Neuropatía óptica isquémica anterior
D) Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE)
E) Catarata nuclear

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE)** (opción **D**). Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 58 · 6.02.1.010 · Degeneración macular relac

Una paciente de 77 años de edad consulta porque, desde hace un año y medio, ha presentado dificultades para la lectura, a pesar de haber cambiado de lentes hace 6 meses. Además, en el último tiempo, nota que ha empeorado sus dificultades para ver con el ojo derecho, con deformación de las imágenes de dicho ojo. Al examen físico, la inspección ocular no tiene alteraciones, los reflejos fotomotor y de acomodación son normales, el rojo pupilar está presenta y la oculomotilidad está conservada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma de ángulo abierto
B) Catarata
C) Desprendimiento de retina
D) Degeneración macular relacionada con la edad
E) Neuritis óptica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Glaucoma de ángulo abierto** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 106 · 6.02.1.009 · Dacriocistitis aguda

Una paciente de 60 años está en espera de cirugía, por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo presenta cuadro de aumento de volumen en la zona medial del ojo derecho, con dolor, eritema y epifora. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar antibióticos orales
B) Indicar masajes y compresiones locales
C) Indicar corticoides tópicos
D) Indicar antibióticos en colirios
E) Resolver quirúrgicamente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar antibióticos orales** (opción **A**). Es una dacriocistitis aguda. Se trata con ATB orales. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 107 6.02.2.010 · Úlcera corneal

Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociada a epifora. Al examen muestra ojo rojo periquerático en el ojo izquierdo, con lagrimeo y una zona de opacidad corneal de 2,1 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Conjuntivitis bacteriana
B) Úlcera corneal
C) Uveítis aguda
D) Glaucoma agudo
E) Blefaritis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Úlcera corneal** (opción **B**). Cuadro clásico. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 179 6.02.2.006 · Hemorragia vítrea

Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierda. Con el ojo izquierdo solo puede contar dedos. Al examen físico no se ven alteraciones externas, pero el rojo pupilar del ojo izquierdo está muy disminuido. El diagnóstico más probable es:

A) Trombosis de la vena central de la retina
B) Desprendimiento de retina
C) Neuritis óptica
D) Embolia de arteria central de la retina
E) Hemorragia vítrea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hemorragia vítrea** (opción **E**). La pérdida del rojo pupilar orienta mucho a hemorragia vítrea. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 157 6.02.2.006 · Hemorragia vítrea

Una paciente de 56 años, diabética de larga data, mal controlada, con nefropatía diabética en etapa IV, presenta pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma
B) Edema macular
C) Uveítis
D) Trombosis de la vena central de la retina
E) Hemorragia vítrea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El antecedente de DM2 con daño renal sugiere una retinopatía diabética proliferativa, que ahora se complicó con hemorragia vítrea. Se debe evaluar el rojo pupilar (que se pierde) para confirmar el diagnóstico.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 91 6.02.2.006 · Hemorragia vítrea

Un paciente de 68 años, diabético de larga data, fumador, presenta pérdida brusca de la visión del ojo derecho, sin dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infarto occipital
B) Desprendimiento de retina
C) Hemorragia vítrea
D) Degeneración macular
E) Edema macular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una HV clásica, que es la causa de ceguera en la retinopatía diabética. La pérdida de rojo pupilar es un signo característico, aunque no se mencione. El infarto occipital daría hemianopsia homónima contralateral. El DR sí pierde la visión, pero suele ser como una caída de telón o levantamiento de pared y estar precedido de fotopsias y entopsias. La DMRE es crónica y la AV disminuye lentamente. El edema macular sí puede producir ceguera, pero demora varios días en instalarse.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 177 6.02.2.006 · Hemorragia vítrea

Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso presenta disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, que solo le permite diferenciar los movimientos de una mano, sin poder identificar letras. La agudeza visual del ojo derecho es normal. La explora- ción externa es normal y el rojo pupilar es negativo en ese ojo. En sus exámenes desta- ca hemoglobina glicosilada de 9,2%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neuritis óptica isquémica
B) Desprendimiento de retina
C) Hemorragia vítrea
D) Trombosis de la arteria central
E) Edema macular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hemorragia vítrea** (opción **C**). Es una hemorragia vítrea clásica, con todo y pérdida de rojo pupilar.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 5 6.02.1.016 · Neuritis óptica

Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución, asociado a leve dolor retroocular derecho, que aumenta con los movimientos. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un escotoma derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probale?

A) Desprendimiento de retina
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Trombosis de arteria central de la retina
D) Neuritis óptica
E) Absceso orbitario

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto la clínica (amaurosis más defecto pupilar aferente o escape pupilar), como la esclerosis múltiple, orientan a Neuritis óptica. La causa más frecuente es autoinmune.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 82 6.02.1.016 · Neuritis óptica

Una paciente, con antecedente de esclerosis múltiple, consulta por dolor ocular derecho, de 2 días de evolución, a lo que se le ha agregado visión borrosa. Tiene agudeza visual de 0,9 en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo, que no cambia al mirar por un agujero estenopeico. Además se constata que en el ojo derecho está muy afectada la visión de colores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Discromatopsia
B) Retinitis pigmentosa
C) Coriorretinitis
D) Desprendimiento de retina
E) Neuritis óptica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una neuritis óptica tanto por el antecedente de EM, como por la cínica, aunque tenía AV normal y no mencionaban el RFM.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 75 6.02.1.006 · Conjuntivitis bacteriana c

Una paciente de 32 años, con antecedentes de asma y rosácea, usuaria de corticoides inhalados, presenta un cuadro de algunos meses de evolución de ojo rojo bilateral, asociado a ardor, epifora y secreción mucosa, que a veces se vuelve purulenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma agudo
B) Blefaritis
C) Uveítis
D) Dacriocistitis
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La clínica parece una conjuntivitis alérgica (antecedente de asma), pero no estaba en las alternativas. El antecedente de rosácea orienta mucho a blefaritis, sin embargo, falta la descripción del eritema y descamación palpebral y le sobra la secreción mucosa y mucopurulenta. La conjuntivitis bacteriana crónica (mayor a 4 semanas) clásicamente se asocia a otras alteraciones, como la blefaritis, y sí tiene secreción mucosa y purulenta, más el ojo rojo. No se describe el aumento de volumen de la dacriocistitis. Es una pregunta difícil y no queda completamente claro cuál es el diagnóstico, pero dejaremos como correcta la conjuntivitis crónica, por el tiempo de evolución, por el factor de riesgo y por la clínica compatible. Es una pregunta muy difícil.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 156 6.02.1.017 · Neuropatía óptica isquémic

Un paciente de 65 años, con antecedente de revascularización miocárdica hace un año y cirugía de cataratas, consulta porque hace algunas horas dejó de ver su pie derecho. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se aprecia oculomotilidad normal, inspección normal y defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho. La campimetría muestra pérdida del campo visual inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Neuritis óptica
B) Degeneración macular relacionada con la edad
C) Accidente vascular encefálico occipital
D) Edema macular
E) Neuropatía óptica isquémica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una amaurosis parcial súbita, lo que sugiere fuertemente una neuropatía óptica isquémica. Por ser la parte inferior del campo visual izquierdo lo afectado, probablemente la lesión se produjo en la parte superior del nervio óptico izquierdo. La neuritis óptica se instala en horas o días, la DMRE demora meses o años, el edema macular demora días y el accidente vascular occipital tiene una hemianopsia contralateral, afectado ambos campos visuales. Finalmente, también podría haber sido un desprendimiento de retina, aunque suele estar precedido por entopsias o fotopsias y avanzar lentamente, como una "caída de telón", "cierre de cortina" o "levantamiento de un muro".

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 170 6.02.1.017 · Neuropatía óptica isquémic

Un paciente de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus 8po 2 y revascularización coronaria hace 3 años, consulta porque hace pocas horas notó que, de forma súbita, dejó de ver su pierna derecha con el ojo derecho. Al examen Fsico presenta inspección ocular normal, agudeza visual 20/30 en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo, pupilas isocóricas con defecto pupilar aferente rela8vo, y en la campimetría por confrontación se observa hemianopsia inferior del ojo derecho. El diagnós8co más probable es:

A) Neuri2s óp2ca isquémica
B) Infarto del lóbulo occipital
C) Desprendimiento de re2na
D) Glaucoma
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por el inicio súbito, con factores de riesgo cardiovascular, como por el defecto pupilar aferente relativo (DPAR), es una neuropaVa óptica isquémica, con afectación de la zona superior del nervio óptico derecho (inerva la zona superior de la reGna y corresponde a la zona inferior del campo visual). El DPAR se ve también en la neuriGs óptica desmielinizante y en el desprendimiento de reGna extenso o en la oclusión de la arteria central de la reGna.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 153 6.02.1.017 · Neuropatía óptica isquémic

Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:

A) Glaucoma agudo
B) Glaucoma crónico terminal
C) Neuritis óptica
D) Neuropatía óptica isquémica
E) Desprendimiento de retina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Parecía una trombosis de la vena central, pero no aparece en las opciones. Por tener DPAR (defecto pupilar aferente relativo) sugiere un desprendimiento de retina, pero le falta tener fotopsias o entopsias que antecedan. Así, dados los antecedentes, lo más probable es la neuropatía óptica isquémica. No puede ser una neuritis óptica, porque esta no es súbita, sino que aparece en varias horas.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 81 6.02.1.030 · Uveítis anterior o posteri

Un paciente de 30 años, con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor, desde hace 24 horas, asociado a disminución de la agudeza visual. Hace 2 años presentó un episodio similar autolimitado, por el que no había consultado. Al examen físico, se muestra lo siguiente: FOTO (Ojo examinado con la luz de hendidura que muestra discoria).

A) Uveítis anterior
B) Catarata
C) Disgenesia pupilar
D) Endoftalmitis
E) Hemorragia vítrea

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Uveítis anterior). Es una uveítis anterior clásica.. La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 46 6.02.1.030 · Uveítis anterior o posteri

Una paciente de 42 años, con antecedente de artritris psoriática e hipertensión arterial, en tratamiento farmacológico, consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a fotofobia y disminución de la agudeza visual de dicho ojo. Al examen físico tiene ojo rojo bilateral, mayor al lado izquierdo, con marcada fotofobia en dicho lado, al examen con linterna. Su agude visual es 20/25 a derecha y 20/40 a izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Uveítis aguda
B) Conjuntivitis viral
C) Glaucoma agudo
D) Neuritis óptica
E) Glaucoma crónica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Glaucoma agudo** (opción **C**). La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 52 6.02.1.030 · Uveítis anterior o posteri

Un paciente de 34 años, tienen antecedente de úlceras orales a repetición y artralgias. Además, presentó una úlcera genital hace algunas semanas. Consulta por dolor en el ojo derecho, asociado a visión borrosa, de dos días de evolución. Al examen físico, se aprecia marcado enrojecimiento del ojo derecho, con agudeza visual 20/100. El diagnóstico más probable es:

A) Úlcera corneal
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Conjuntivitis viral
D) Uveítis
E) Queratitis aguda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una enfermedad de Behçet, que se asocia a uveítis, al igual que las PEA y las EII. La A, C y E no afectan la agudeza visual. La B no tiene ojo rojo.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 98 6.02.1.030 · Uveítis anterior o posteri

Paciente con psoriasis, disminución de agudeza visual, ojo rojo profundo y fotofobia importante. ¿Diagnóstico más probable?

A) Uveítis anterior aguda
B) Epiescleritis
C) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
D) Conjuntivitis bacteriana aguda
E) Queratitis herpética

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Uveítis anterior aguda** (opción **A**). Uveítis anterior aguda. La celulitis orbitaria es una patología que el médico general debe saber clasificar y manejar de manera urgente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 156 6.02.1.029 · Tumores endoculares (retin

Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinoblastoma
B) Glaucoma congénito
C) Catarata congénita
D) Retinopatía del prematuro
E) Tumor de órbita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Retinoblastoma** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Glaucoma congénito, Catarata congénita) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 83 · 6.02.1.029 · Tumores endoculares (retin

Un niño de 8 meses presenta leucocoria del ojo derecho. Como antecedente, su madre usa una prótesis ocular, por una pérdida ocular en su infancia, por una causa no precisada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinopatía del prematuro
B) Catarata congénita
C) Retinoblastoma
D) Glaucoma congénito
E) Infección por Chlamydia trachomatis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El retinoblastoma suele tener agregación familiar (gen Rb) y además es causa de leucocoria. La catarata habría tenido leucocoria desde el inicio.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 147 · 6.02.1.013 · Glaucoma crónico

Un paciente de 42 años se realiza una tonometría ocular que informa una presión intraocular de 27 mmHg. Presenta una excavación papilar de 0.7 en el ojo derecho y en la gonioscopía se observa ángulo abierto en todo el contorno del iris. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinopatía diabética
B) Neuritis óptica
C) Glaucoma crónico
D) Coriorretinitis
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Glaucoma Crónico: Una presión ocular mayor a 20 mmHg se considera elevada. La excavación papilar mayor a 0.3 también sugiere glaucoma crónico o de ángulo abierto. La gonioscopía, que examina el ángulo de drenaje del ojo, suele mostrar un ángulo abierto en este tipo de glaucoma.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 84 · 6.02.1.013 · Glaucoma crónico

Una paciente de 50 años se realiza una tonomotría ocular, que muestra una presión intraocular de 28 mmHg en el ojo derecho. La inspección ocular no tiene alteracios. La agudeza visual es 1,0 en ambos ojos y se constata una excavación papilar es de 0,7 a derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Neuropatía óptica
C) Glaucoma crónico
D) Catarata
E) Desprendimiento de retina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un glaucoma crónico clásico, tanto por la PIO mayor a 20, como por la excavación papilar mayor a 0,3.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 166 · 6.02.1.013 · Glaucoma crónico

Un paciente de 60 años, diabético, hipertenso y dislipidémico, con antecedente de artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato, consulta por disminución progresiva de la calidad de la visión. A su examen físico, la exploración ocular es normal, con rojo pupilar normal bilateral. La agudeza visual es 20/25 en ambos ojos. La campimetría muestra defectos visuales en los dos cuadrantes superiores del campo visual izquierdo y en los dos cuadrantes mediales del campo visual derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Tumor del lóbulo occipital
C) Catarata
D) Glaucoma crónico
E) Neuropatía óptica isquémica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un glaucoma crónico clásico, con afectación del campo visual, de predominio periférico y agudeza visual conservada. La DMRE afecta la AV, al igual que la catarata y la NOI. El tumor occipital produciría una hemianopsia homónima (ej. solo derecho o solo izquierdo, pero no bimedial).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 155 · 6.02.1.013 · Glaucoma crónico

Una paciente de 67 años, con antecedente de artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexato y prednisona, consulta por dificultades para ver. Tiene historia de cirugía de cataratas hace dos años. Al examen oftalmológico se constata agudeza vidual 20/25 a derecha y 20/30 a izquierda y, en la campimetría visual, se observa afectación de la zona medial del campo visual derecho y de la zona superior del campo visual izquierdo. El diagnóstico más probable es:

A) Desprendimiento de retina
B) Lesión del quiasma óptico
C) Glaucoma crónico
D) Neuritis óptica
E) Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene agudeza visual normal, pero afectación del campo visual, lo que sugiere un glaucoma crónico. Se asocia al uso de corticoides y alos factores de riesgo cardiovascular.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 114 · 6.02.1.013 · Glaucoma crónico

Paciente con glaucoma crónico, con ojo izquierdo con visión en túnel y ojo derecho con el signo de humo de chimenea, al evaluar el ojo con glaucoma crónico, ¿qué hallazgo tendría?:

A) Midriasis arreflectica
B) Reflejo ?/
C) Miosis
D) Defecto pupilar aferente (esta porque la principal complicación del glaucoma crónico es el daño del nervio óptico que se vería con un DPA)
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Midriasis arreflectica). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Reflejo ?/, Miosis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 163 6.02.1.013 · Glaucoma crónico

Paciente con vision tubular, y un signo de humo de chimenea en el ojo _. Visión derecho digital? e izq 20/20. Reflejo fotomotor alterno/RFM alterado creo . ¿Cuál es el diagnóstico? ALGUIEN QUE MEJORE ESTA PREGUNTA A LAS ALTERNATIVAS: me parece que esta tenía glaucoma de ángulo abierto en las alternativas?

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Hemograma y VHS** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 171 6.02.1.003 · Catarata

Pregunta 171 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 78 años presenta disminución de la visión del ojo derecho, de 4 meses de evolución. Al examen tiene caída de la agudeza visual de dicho ojo, con disminución de la visión del contraste y afectación del rojo pupilar. El diagnóstico más probable es:

A) Glaucoma crónico
B) Catarata
C) Degeneración macular relacionada con la edad
D) Vicio de refracción
E) Atrofia del nervio óptico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Catarata** (opción **B**). Es una catarata clásica.. La pérdida súbita de visión es una emergencia oftalmológica que puede tener múltiples etiologías, cada una con características clínicas y hallazgos específicos que permiten orientar el diagnóstico. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 33 6.02.1.003 · Catarata

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 15/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinopatía diabética
B) Edema macular
C) Catarata
D) Glaucoma
E) Hemorragia vítrea

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una catarata clásica por la disminución de la AV y por la alteración del rojo pupilar (la opacidad como estrella es la catarata misma). La RD no tiene síntomas; el edema macular tiene disminución de la AV en pocos días y no altera el rojo pupilar. El glaucoma no afecta la AV, sino el campo visual y no afecta el rojo pupilar. La HV tiene aparición súbita y se pierde el rojo pupilar.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 16 6.02.1.003 · Catarata

Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 10/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar de- muestra una opacidad con forma de estrella, en la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento de retina
B) Edema macular
C) Catarata
D) Glaucoma
E) Retinopatía diabética proliferativa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Catarata** (opción **C**). Es una catarata inicial.. La pérdida súbita de visión es una emergencia oftalmológica que puede tener múltiples etiologías, cada una con características clínicas y hallazgos específicos que permiten orientar el diagnóstico. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 31 6.02.1.003 · Catarata

Lactante de 7 meses cuya madre nota que al iluminar sus ojos con linterna, el ojo derecho refleja luz blanca (leucocoria) en vez del habitual reflejo rojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Descartar toxoplasmosis ocular: solicitar serología
B) Catarata congénita: derivar urgente a oftalmología
C) Retinoblastoma: derivar urgente a oftalmología
D) Retinopatía del prematuro: si no fue prematuro, tranquilizar
E) Glaucoma congénito: iniciar colirio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Leucocoria (reflejo pupilar blanco) en lactante: principal diagnóstico a descartar es CATARATA CONGÉNITA y retinoblastoma. A los 7 meses sin antecedente de prematuridad, catarata congénita es lo más frecuente. Derivación urgente a oftalmología para tratamiento precoz (cirugía antes de los 10 semanas para evitar ambliopía).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 156 6.02.1.003 · Catarata

Paciente con agudeza visual 20/40 bilateral que no mejora con agujero estenopeico. Refracción sin cambios. ¿Cuál es la causa más probable de esta alteración visual?

A) Opacidad de medios (catarata u otra causa no refractiva)
B) Error refractivo no corregido
C) Ambliopía
D) Glaucoma
E) Degeneración macular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El agujero estenopeico mejora la AV solo en errores refractivos. Si NO mejora, la causa es una opacidad de medios (catarata, opacidad corneal, vítreo) o patología retinal/neural. En adulto: pensar en catarata.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 83 6.02.1.012 · Glaucoma congénito

Un lactante de 5 meses, con antecedente de haber nacido a las 35 semanas, presenta cambios en el aspecto de sus ojos, sin otros síntomas. Se realiza medición del diámetro corneal, que resulta 14 mm (VN: 10 a 12 mm) y prueba de fluoresceína, con aclaramiento de 5 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A) Glaucoma congénito
B) Atresia de la vía lagrimal
C) Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
D) Ambliopía
E) Retinopatía del prematuro

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Glaucoma Congénito: La epífora, megalocórnea y buftalmos sugieren glaucoma congénito. La prueba de fluoresceína con aclaramiento lento es compatible con dacriocistitis congénita y glaucoma congénito. El valor normal del aclaramiento de fluoresceína es menor a 5 minutos.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 31 6.02.1.012 · Glaucoma congénito

Un lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociado a epifora y au- mento del diámetro corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinoblastoma
B) Macrocórnea
C) Glaucoma congénito
D) Atresia lagrimal
E) Catarata congénita

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Glaucoma congénito** (opción **C**). Es un glaucoma congénito clásico.. La retinopatía del prematuro (ROP) es una de las causas más importantes de ceguera infantil prevenible. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 125 6.02.1.001 · Ametropía

Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8, al mirar por un agujero estenopeico. No presenta do- lor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma
B) Estrabismo
C) Vicio de refracción
D) Catarata
E) Coriorretinitis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La mejora de la AV al mirar por un agujero estenopeico es característico de los vi- cios de refracción.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 95 6.02.1.001 · Ametropía

Un niño de 5 años, nacido a las 32 semanas por parto vaginal, es llevado a control porque se acerca mucho a la pantalla cuando ve televisión. La inspección ocular es normal. La agudeza visual es de 20/25 en el ojo derecho y 20/80 en el ojo izquierdo, la cual mejora a 20/25 al usar un agujero estenopeico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ambliopía
B) Microftalmia
C) Ametropía
D) Glaucoma congénito
E) Retinopatía del prematuro

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Vicios de Refracción y Agudeza Visual: La mejora de la agudeza visual al mirar a través de un agujero estenopeico es característica de los vicios de refracción, también conocidos como ametropías. En este caso, no hay ambliopía porque la agudeza visual se corrige completamente. Si la agudeza visual solo hubiera mejorado parcialmente con la corrección de la ametropía, el diagnóstico también habría incluido ambliopía anisometrópica.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 40 6.02.1.001 · Ametropía

Un niño de 6 años consulta por dificultades para ver. Al examen físico destaca agudeza visual de 20/60, que cambia a 20/30, al mirar por un agujero estenopeico. La madre refiere que siempre se restriega los ojos. El diagnóstico más probable es:

A) Blefaritis
B) Conjuntivitis viral
C) Ametropía
D) Conjuntivitis bacteriana crónica
E) Glaucoma congénito

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una caída de la AV que mejora al mirar por un agujero estenopeico, así que tiene un vicio de refracción, también llamado ametropía. La AV pasó de 0,33 a 0,67, por lo que mejoró (se calcula con la simple división de 20/60 y 20/30).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 163 6.02.1.002 · Blefaritis

Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo iz- quierdo, que se muestra en la siguiente foto: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amoxicilina
B) Azitromicina
C) Aciclovir
D) Mupirocina
E) Dexametasona

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Aciclovir** (opción **C**). Era un herpes periocular.. La queratitis herpética produce una úlcera dendrítica o en helecho, prácticamente patognomónica de herpes simple ocular, tratamiento con aciclovir tópico y oral. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 60 6.02.1.018 · Obstrucción completa de la

Un niño de 4 meses de edad consulta por epifora del ojo izquierdo y eritema, que no ha respondido al uso de antibióticos tópicos. Al examen físico se aprecia edema y aumento de volumen de la zona medial, con borramiento de la hendidura palpebral y reflujo al comprimir el saco lagrimal. El diagnóstico más probable es:

A) Glaucoma congénito
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Atresia lagrimal congénita
D) Queratitis por Chlamydia trachomatis
E) Dacriocele

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una atresia lagrimal clásica. No tien buftalmo ni opacidad corneal, como para pensar en glaucoma congénito.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 173 6.02.2.001 · Causticaciones oculares

Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 20 minutos le saltó una solución de soda cáustica en la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:

A) Ungüento antibiótico y parche ocular
B) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
C) Hielo local
D) Corticoides tópicos
E) Analgésicos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La causticación ocular se maneja con lavado con abundante agua o SF por 30 minutos. No confundir con las perforaciones oculares, que no se debe tocar el ojo ni aplicarle nada, sino solo analgésicos y antibióticos por vía endovenosa y derivación urgente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 175 6.02.2.001 · Causticaciones oculares

Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 30 minutos le saltó una solución de soda cáustica caliente a la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:

A) Analgésicos
B) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
C) Antibióticos tópicos
D) Corticoides tópicos
E) Parche ocular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las causticaciones oculares (con ácidos, álcalis y otros irritantes) se manejan con lavado abundante con suero fisiológico o agua, por 30 minutos y luego ATB tópicos. El parche es discutible, ya que da miedo que se adhiera el párpado al globo ocular.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 38 6.02.1.011 · Estrabismo

Un niño de 2 meses presenta estrabismo bilateral, fluctuante y que aparece con bastante frecuencia. Ha incrementado bien de peso y no tiene otros síntomas. Se realiza examen ocular, que muestra rojo pupilar presente bilateral, sin defectos y movilidad ocular sin alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar fondo de ojo
B) Derivar a oftalmólogo pediátrico
C) Indicar parches oculares intermitentes
D) Solicitar TAC de órbitas
E) Mantener el control habitual del niño sano

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener el control habitual del niño sano** (opción **E**). El tratamiento del glaucoma congénito es siempre quirúrgico con goniotomía o trabeculotomía; el tratamiento médico es solo transitorio previo a la cirugía. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 112 6.02.1.028 · Tumores de párpado

Adulto que consulta por lesión pruriginosa de 3 meses en párpado inferior que aumentó de volumen. ¿Diagnóstico más probable?

A) Chalazión crónico
B) Orzuelo interno
C) Carcinoma basocelular
D) Carcinoma espinocelular
E) Melanoma ocular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Carcinoma basocelular** (opción **C**). Carcinoma basocelular. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 176 6.02.1.028 · Tumores de párpado

Un paciente de 70 años consulta por aparición de una lesión pruriginosa en el párpado inferior izquierdo, que comenzó como un pequeño nódulo hace un año y que ha crecido al tamaño que se observa en la siguiente imagen (Fuente: https://hospitaluvrocio.es/): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Orzuelo
B) Chalazión
C) Melanoma
D) Carcinoma basocelular
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Carcinoma basocelular** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 1 · 6.02.2.007 · Herida penetrante o perfor

Niño con aumento volumen de párpado, eritema, y secreción purulenta, no puede abrir el ojo: a. Celulitis periorbitaria (sin oftalmoplejia, dolor al mover el ojo, proptosis, disminución de la agudeza visual) Según yo salia que no podía abrir el ojo, decía literalmente “dolor al-1hh1-examen oftalmológico, eso se puede ſasumir como dolor a la oculomotilidad)

B) celulitis orbitaria
C) Chalazion infectado
C) Control sano habitual
D) Derivar a especialista
E) Hospitalizar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (celulitis orbitaria, Chalazion infectado) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 71 · 6.02.2.003 · Desprendimiento de retina

Pérdida de agudeza visual en días, que alcanzaba a contar dedos y tenía defecto pupilar aferente, Entopsias y fotopsias: a. Desprendimiento de retina

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 156 · 6.02.1.021 · Queratitis

Una paciente de 42 años consulta por dolor ocular derecho, asociado a ojo rojo que inició hace 5 horas y se ha vuelto muy intenso. Al examen Fsico, presenta epífora y ojo rojo derecho de 8po central. Como antecedente, 8ene as8gma8smo y es usuaria de lentes de contacto. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?

A) Fondo de ojo
B) Tonometría ocular
C) TAC de órbitas
D) Tinción con fluoresceína
E) Gonioscopía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha clínica es una queraGGs o una erosión corneal. El uso de lentes de contacto podría ser la causa. Con la Gnción con fluoresceína se pueden ver mejor las úlceras y erosiones corneales. La genioscopía es úGl en la evaluación del glaucoma agudo.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 19 · 6.02.1.021 · Queratitis

Una paciente de 45 años con antecedente de artri8s reumatoide, en tratamiento con micofenolato y terapia biológica, consulta por dolor ocular, epífora y ojo rojo bilateral asociado a fotofobia. Refiere que los síntomas empeoran en la tarde, al término de su jornada laboral. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Quera22s
B) Uveí2s
C) Glaucoma agudo
D) Conjun2vi2s viral
E) Celuli2s orbitaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Aunque la artriGs reumatoide se asocia a escleriGs y uveíGs, también puede producir ojo seco, por síndrome de Sjögren secundario, el que se asocia a queraGGs. En este caso, la clínica orienta a una queraGGs sicca clásica.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 114 · 6.02.1.024 · Síndrome de ojo seco

Paciente de 40 años con ojo rojo, sensación de arenilla, lagrimeo y fotofobia desde hace 3 meses. Usa lentes de contacto hace años. Antecedente de artritis reumatoide. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de ojo seco (queratoconjuntivitis sicca)
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Úlcera corneal por Acanthamoeba
D) Escleritis
E) Glaucoma agudo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síntomas crónicos de ojo seco (arenilla, lagrimeo reflejo, fotofobia) + artritis reumatoide (síndrome de Sjögren secundario) = queratoconjuntivitis sicca. Tratamiento: lágrimas artificiales.

DERMATOLOGÍA

Módulo 2: Cirugía y Especialidades · Colección Tomo 16

57 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

27 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.01.1.001	Acné	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.002	Alopecías	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · 16.2 (Pág. 7)
6.01.1.003	Cáncer de piel no melanoma	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 16 · 16.3 (Pág. 9)
6.01.1.007	Dermitis de contacto	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.011	Fotodermatosis	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.012	Granuloma piogénico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.013	Hemangiomas cutáneos infantiles	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.014	Linfomas cutáneos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.016	Lupus eritematoso cutáneo crónico (lupus discoide)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.017	Melanoma maligno	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.018	Micosis superficiales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.021	Piodermias superficiales y profundas (no linfáticas)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.022	Pitiriasis Rosada de Gilbert	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.024	Psoriasis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.025	Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.026	Rosácea	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.027	Sarna	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.028	Tumores benignos de piel	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.029	Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.030	Urticaria aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.1.031	Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.003	Erisipela / Celulitis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 16 · 16.10 (Pág. 33)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.01.2.009	Herpes zoster	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.011	Loxocelismo	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.2.013	Necrolisis tóxica epidérmica	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.3.003	Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)
6.01.5.001	Biopsia de piel	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 16 · Dermatología (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 17 6.01.1.027 · Sarna

Un paciente de 35 años consulta por intenso prurito en la zona genital de una semana de evolución. Al examen físico, se observan lesiones escrotales, que se muestran en la imagen (fuente: https://rafalafena.wordpress.com/wp- content/uploads/2022/03/....). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Prúrigo nodular
B) Infección por virus papiloma humano
C) Sífilis primaria
D) Escabiosis
E) Sífilis secundaria

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Sarna Nodular: La presencia de prurito en la zona genital puede ser compatible con escabiosis (sarna) o infestación por ladillas (Phthirus pubis). Sin embargo, si las imágenes muestran lesiones nodulares características, se confirma el diagnóstico de sarna nodular.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 108 6.01.1.027 · Sarna

Embarazada de 30 semanas, sin antecedentes, consulta por lesiones eritematosas en antebrazos, genitales, manos y tronco, asociadas a prurito. Al examen físico se aprecian lesiones eritematosas pápulares y maculares en patrón sinuoso, con signos de grataje, por lo que se decide realizar un ácaro test, que resulta positivo. El tratamiento de elección, en este caso es:

A) Permetrina oral
B) Puvaterapia
C) Corticoides locales
D) Permetrina tópica al 5%
E) Vaselina azufrada

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Vaselina azufrada** (opción **E**). Sarna en embarazo = vaselina azufrada. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 91 6.01.1.027 · Sarna

Una mujer de 34 años, cursando embarazo de 23 semanas, presenta lesiones pruriginosas en abdomen, manos y zona inguinal, que han ido en aumento en la úl8ma semana. Al examen Fsico se aprecian signos de rascado, pápulas y surcos en la zona interdigital y antebrazos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Betametasona tópica
B) Vaselina azufrada tópica
C) Loción de permetrina 5% tópica
D) Ivermec2na oral
E) Prednisona oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discuGble. La normativa chilena vigente es muy antigua (Norma técnica 101 Minsal del año 2007, aunque ha sido replicada en normas más actuales) y aún prioriza la vaselina azufrada por su inocuidad total en embarazadas, lactancia y niños menores de 2 meses (por eso la dejaremos como correcta, ya que probablemente fue la correcta en el examen). Sin embargo, la evidencia moderna es clara en que la permetrina al 5% es actualmente el tratamiento de elección incluso en embarazadas y lactancia, siendo únicamente discuGble en menores de 2 meses, en los que no hay suficientes estudios.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 4 6.01.1.027 · Sarna

Clínica de Sarna (perlada) con acarotest negativo manejo:

A) Permetrina
B) Ivermectina
C) Repetir acarotest
D) Vaselina azufrada
E) Amoxicilina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Permetrina** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Ivermectina, Repetir acarotest) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 44 6.01.1.018 · Micosis superficiales

Un paciente de 40 años consulta por hiperqueratosis y cambio de coloración de las uñas de los ortejos, de algunos meses de evolución. Se realiza estudio micológico, que muestra presencia de Trichophitum rubrum. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Itraconazol
B) Griseofulvina
C) Fluconazol
D) Terbinafina
E) Clotrimazol

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Terbinafina** (opción **D**). La terbinafina oral es el tratamiento de elección de la onicomicosis.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 20 6.01.1.018 · Micosis superficiales

Un escolar de 7 años consulta por una zona alopécica de 2 semanas de evolución, que ha ido en creciendo. Al examen físico se aprecia la placa alopécica de 4 cm, con des- camación y pelos entrecortados, tal como se muestra en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tiña capitis
B) Tricotilomanía
C) Alopecia areata
D) Lupus discoide
E) Dermatitis solar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Tiña capitis** (opción **A**). Tiña capitis clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 85 6.01.1.018 · Micosis superficiales

Una paciente de 50 años, diabética, con antecedente de insuficiencia renal e hígado graso, consulta por lesiones pruriginosas y eritematosas debajo de las mamas, en la región inguinal y debajo del abdomen. El tratamiento más adecuado es:

A) Mupirocina tópica
B) Cefadroxilo oral
C) Griseofulvina oral
D) Fluconazol oral
E) Ketoconazol tópico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un intétrigo candidiásico. Por el antecedente de IRC y hepatopatía, se prefieren los antimicóticos tópicos.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 176 6.01.1.018 · Micosis superficiales

Una paciente de 70 años, diabética en tratamiento farmacológico y con obesidad, consulta por lesiones en el tórax, asociadas a prurito. Al examen físico de pliegues mamarios se encuentran lesiones eritematosas asociadas a rezumación con pequeñas pústulas blancas. El diagnóstico más probable es:

A) Acrocordones
B) Intértrigo candidiásico
C) Impétigo buloso
D) Tiña corporis
E) Psoriasis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Intértrigo candidiásico** (opción **B**). Es un intértrigo: infección por hongos en los pliegues. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 120 6.01.1.024 · Psoriasis

Mujer de 35 años con placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas de escamas plateadas en rodillas y codos, con fenómeno de Auspitz positivo. Compromete el 10% de la superficie corporal. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Psoriasis en placas
B) Dermatitis atópica
C) Dermatitis de contacto
D) Liquen plano
E) Micosis fungoide

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Placas eritematosas con escamas plateadas en superficies extensoras + fenómeno de Auspitz (sangrado puntiforme al retirar escama) = psoriasis en placas. Compromiso 10% = psoriasis moderada.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 88 6.01.1.024 · Psoriasis

Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, consulta por aparición de placas eritematodescamativas en las rodillas y los codos. El diagnóstico más probable es:

A) Dermatittis de contacto
B) Psoriasis vulgar
C) Tiña corporis
D) Pitiriasis rosada de Gibert
E) Dermatitis atópica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Psoriasis vulgar** (opción **B**). Cuadro clásico. La psoriasis vulgar es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmune que afecta aproximadamente al dos por ciento de la población mundial. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 86 6.01.1.031 · Verrugas, herpes simplex,

Un niño de 8 años presenta una lesión en la cara lateral del primero ortejo derecho. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, hiperqueratósica, con puntos negros en su superficie, la que se muestra en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Queratosis seborreica
B) Melanoma
C) Panadizo
D) Verruga vulgar
E) Cuerpo extraño periungueal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una verruga paraungueal clásica. La descripción era muy clara. La imagen era algo más confundente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 177 6.01.1.031 · Verrugas, herpes simplex,

Un paciente de 23 años consulta por aparición de lesiones dolorosas y pruriginosas en los pies, que aparecieron hace un mes y han aumentado. Al examen físico, se aprecia lo siguiente (fuente: podologíapriego): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tiña pedis
B) Verrugas plantares
C) Granuloma piógeno
D) Queratosis seborreica
E) Molusco contagioso

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Verrugas plantares** (opción **B**). Son verrugas plantares clásicas.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 89 6.01.1.031 · Verrugas, herpes simplex,

Adolescente de 20 años, consulta por la siguiente lesión, en el pliegue interglúteo, que presenta prurito y ardor: El diagnóstico más probable es:

A) Picadura de insecto
B) Consilomas acuminadas
C) Herpes simplex
D) Impétigo ampollar
E) Erisipela

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Herpes simplex** (opción **C**). Imagen clásica. Es una recurrencia de herpes genital probablemente.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 43 6.01.1.031 · Verrugas, herpes simplex,

Un paciente adulto mayor, diabético, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, como se ve en la siguiente imagen: El tratamiento más adecuado es:

A) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 5 días
C) Aciclovir tópico
D) Loratadina 10 mg al día por 5 días
E) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un herpes zóster. Sirven tanto el aciclovir, como el valaciclovir, pero solo la dosis del valaciclovir estaba bien, porque la de aciclovir, para herpes zóster es 800 mg cada 4 horas, por 5 a 7 días.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 30 6.01.1.031 · Verrugas, herpes simplex,

Un niño de 8 años presenta lesiones dolorosas en la espalda (pregunta original estaban en el cuello y zona dorsal alta), de 2 días de evolución, que se muestran a continuación (fuente: alamy stock photo): ¿Qué tratamiento es más adecuado?

A) Mupirocina tópica
B) Aciclovir oral
C) Betametasona tópica
D) Fluconazol tópico
E) Cloxacilina oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Aciclovir oral** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Mupirocina tópica, Betametasona tópica) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 48 6.01.2.013 · Necrolisis tóxica epidérmi

Una paciente de 26 años, se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre y dolor cutáneo generalizado, con eritema generalizado de la piel y compromiso de las mucosas. Hace algunas horas comienza con aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa lo mostrado en la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:

A) Psoriasis eritrodérmica
B) Escarlatina quirúrgica
C) Pustulosis exantemática
D) Necrosis epidermolítica tóxica
E) Pénfigo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una NET clásica, con el signo de Kikolski (se desprende la epidermis), aunque no era la imagen más característica de la NET.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 94 6.01.2.013 · Necrolisis tóxica epidérmi

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades, con lesiones en la cara similares a las de la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Pénfigo
E) Escarlatina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico con compromiso de mucosas (oral, ocular), rash cutáneo con pápulas/placas eritematosas y antecedente de uso de antibiótico (amoxicilina) son característicos del síndrome de Stevens-Johnson.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 80 6.01.2.013 · Necrolisis tóxica epidérmi

Una paciente de 45 años inicia tratamiento an8bió8co debido a una infección dental. Al sép8mo día de tratamiento presenta erupción papulovesicular generalizada y progresiva, que afecta tronco y extremidades, asociada a fiebre y malestar general. Al examen Fsico se aprecia lo siguiente: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Síndrome DRESS
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Síndrome de piel escaldada
E) Pénfigo ampollar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una NET clásica, por la extensión generalizada y el desprendimiento de la epidermis en la imagen. El SSJ es la misma patología, pero más leve, con afectación de menos del 10% de la superficie cutánea.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 103 6.01.2.013 · Necrolisis tóxica epidérmi

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea hace 14 días, presenta ardor ocular, lesiones en la boca, malestar general y rash cutáneo con eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Pénfigo
E) Escarlatina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico presentado es característico del síndrome de Stevens-Johnson: compromiso multimucosal (oral, ocular), exantema con lesiones en diana/targets, en contexto de uso de fármaco desencadenante (amoxicilina).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 144 6.01.1.007 · Dermitis de contacto

Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una semana. Al examen físico se observa la siguiente imagen: El diagnóstico más probable es:

A) Celulitis
B) Erisipela
C) Dermatitis de contacto alérgica
D) Dermatitis de contacto irritativa
E) Piodermitis superficial

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Faltaba información y no era posible ver bien la imagen. Podría ser una dermatitis de contacto alérgica, porque era en relación a un aro y excedía la zona de contacto, pero las lesiones en la cara no calzaban del todo. La visualización de costras melicéricas es muy sugerente de impétigo (piodermitis superficial), pero también puede verse en la dermatitis de contacto y el cuadro es clásico de esta enfermedad. No puede ser celulitis, porque no hay tejido celular subcutáneo en la oreja.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 143 6.01.1.007 · Dermitis de contacto

Un paciente de 83 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, institucionalizado, presenta lesiones en las piernas, de 4 meses de evolución, que se muestran a continuación (www.mdsaude.com): ¿Cuál es el la conducta más adecuada?

A) Mupirocina tópica
B) Flucloxacilina oral
C) Vendas elásticas
D) Biopsiar las lesiones
E) Vaselina más betametasona tópica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Vaselina más betametasona tópica** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 86 6.01.1.021 · Piodermias superficiales y

Un adolescente consulta por aparición de lesiones en zona nasogeniana, eritematosas, pruginosas, desde hace una semana. Al examen físico se aprecian costras melicéricas en la zona descrita. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amoxicilina más ácido clavulánico
B) Macrólidos
C) Betametasona
D) Cefoperazona
E) Ciprofloxacino

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un impétigo. Cloxacilina o cefadroxilo habrían sido de elección, pero la amoxicilina más ácido clavulánico cubren bien al S. Aureus y al S. Pyogenes, que son los agentes etiológicos.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 111 6.01.1.021 · Piodermias superficiales y

Niño de 7 años con tres lesiones eritematosas con costra melicérica en el abdomen, pruriginosas, sin fiebre. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Mupirocina tópica al 2%
B) Amoxicilina oral 7 días
C) Cefadroxilo oral 10 días
D) Clindamicina oral
E) Peróxido de benzoilo tópico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Impétigo no bulloso localizado (3 lesiones pequeñas) sin fiebre: tratamiento tópico con mupirocina al 2% es suficiente y de primera línea. ATB oral se reserva para enfermedad extensa o sistémica.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 55 6.01.1.021 · Piodermias superficiales y

Un paciente de 21 años consulta por aparición de lesiones cutáneas en la zona glútea de 6 días de evolución, consistentes en pápulas y pústulas, que están en estrecha relación con los folículos pilosos. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A) Flucloxacilina
B) Cejriaxona
C) Doxiciclina
D) Amoxicilina
E) Azitromicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La foliculiGs es causada por Staphylococcus aureus. Se trata con cloxacilina, flucloxacilina, cefadroxilo u otro antibiótico con acción antiestafilocócica (ej. clindamicina en alérgicos). Si es leve, se puede observar. Siempre se trata la causa (ej. roce de ropa nueva).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 45 6.01.1.021 · Piodermias superficiales y

Una paciente de 35 años, consulta por dolor de en la zona escapular izquierda, que comenzó hace un día. Además, notó la aparición de una lesión cutánea. Al examen físico, se aprecia una lesión de 10 cm de diámetro, con centro oscuro, como se ve a continuación: ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Loxosceles laeta
B) Staphilococcus aureus
C) Estreptococo betahemolítico grupo B
D) Pseudomona aureginosa
E) Latrodectus mactans

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Pseudomona aureginosa). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Loxosceles laeta, Staphilococcus aureus) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 80 6.01.1.003 · Cáncer de piel no melanoma

Un hombre de 70 años, consulta por una lesión en la mano derecha, que apareció hace 6 meses y que ha crecido progresivamente. Es dolorosa y se ulcera y sangra con facilidad. Al examen físico se aprecia una lesión escamosa, ulcerada, de 2 cm de diámetro. Como antecedente, trabajó por 20 años, como minero, en la región de Tarapacá. El diagnóstico más probable es:

A) Carcinoma espinocelular
B) Carcinoma basocelular
C) Melanoma maligno
D) Granuloma piógeno
E) Queratosis actínica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un carcinoma espinocelular clásico, en especial porque se describe como escamosa y ulcerada y tiene antecedente de fotoexposición. Los demás cánceres también se pueden ulcerar. El granuloma piógeno sangra mucho, pero es de aspecto rojo y húmedo.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 88 6.01.1.003 · Cáncer de piel no melanoma

Una paciente de 84 años consulta por aparición de una lesión en la zona supraciliar izquierda, hace 12 meses, pruriginosa, que en ocasiones se ulcera y sangra. Al examen físico se observa lo siguiente: FOTO (Mujer adulta mayor con lesión ulcerada en la zona supraciliar, borde eritematoso, de 1 cm de diámetro aprox.). El diagnóstico más probable es:

A) Carcinoma basocelular
B) Queratosis actínica
C) Queratosis seborreica
D) Granuloma piógeno
E) Melanoma acrómico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Carcinoma basocelular** (opción **A**). Si bien la imagen no era un cáncer basocelular clásico, esa era la única respuesta aceptable.. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 84 6.01.1.003 · Cáncer de piel no melanoma

Un paciente de 83 años, calvo, con antecedente de múltiples queratosis actínicas en la cabeza, presenta una lesión en el cuero cabelludo, que notó hace 3 meses y que ha ido creciendo hasta alcanzar un diámetro de 2 x 3 cm. Se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Melanoma
B) Impétigo
C) Dermatitis de contacto
D) Quemadura solar
E) Carcinoma espinocelular

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto por las queratosis actínicas (premalignas, que evolucionan a cáncer espinocelular) como por la imagen, tiene un cáncer espinocelular.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 111 6.01.1.003 · Cáncer de piel no melanoma

IMAGEN: Calvo con antecedente de queratosis actínica, muestran lesión en cabeza: a. Carcinoma espinocelular

A) Derrame pleural
B) Neumotórax
C) Neumonía
D) Atelectasia
E) Masa pulmonar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Derrame pleural). La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 63 6.01.1.003 · Cáncer de piel no melanoma

Una paciente de 58 consulta por aparición de una lesión pruriginosa, de 3 meses de evolución en el párpado inferior derecho, que ha aumentado de volumen. Al examen físico, se observa lo siguiente: Foto 5 (https://martindevoto.com/XXXXXXXXXXX-foto/). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Orzuelo
B) Verruga vulgar
C) Herpes simplex
D) Carcinoma basocelular
E) Chalazión

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Carcinoma basocelular** (opción **D**). Es un cáncer basocelular clásico.. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la cara que se caracteriza por no tener comedones, lo que la diferencia del acné. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 89 6.01.2.011 · Loxocelismo

Una paciente consulta por aparición de una lesión en el atebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que luego de 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico, se aprecia lo siguiente: FOTO (típica placa livedoide en el antebrazo).

A) Loxsocelismo cutáneo
B) Necrosis grasa
C) Ectima
D) Pioderma gangrenoso
E) Fasceítis necrotizante

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Loxsocelismo cutáneo). Es un loxsocelismo cutáneo clásico.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 149 6.01.2.011 · Loxocelismo

Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Latrodectus mactans (araña del trigo)
B) Paederus irritans (bicho candela)
C) Miasis cutánea
D) Loxosceles laeta (araña de rincón)
E) Picadura de abeja con reacción local

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Loxosceles laeta (araña de rincón)). Loxosceles laeta (araña de rincón). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 115 6.01.1.011 · Fotodermatosis

Un paciente de 25 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades in- feriores. Refiere que ayer estuvo jugando fútbol y que las lesiones empezaron a apare- cer después. Además, dice que hace un año, le había pasado algo similar, luego de an- dar en moto por los cerros. Al examen físico se observan lesiones como las que se mues- tran en la siguiente imagen: INSERTAR FOTO (la imagen original mostraba ambos muslos y piernas con múltiples le- siones eritemato-violáceas, muchas de ellas con disposición lineal) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fitodermatitis
B) Enfermedad ampollar
C) Urticaria solar
D) Lupus discoide
E) Vasculitis leucocitoclástica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fitodermatitis** (opción **A**). Era una fitofotodermatosis por litre (árbol de la zona central chilena).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 61 6.01.1.026 · Rosácea

Una paciente de 30 años consulta por aparición de eritema, pápulas y pústulas en ambas mejillas, de varios meses de evolución, que aumentan con la exposición solar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acné del adulto
B) Rosácea
C) Dermatomiositis
D) Erupción polimorfa solar
E) Lupus cutáneo crónico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una rosácea clásica: aumenta con la exposición solar. El lupus sistémico también puede afectar las mejillas y aumentar con el sol, pero no tiene tantas pústulas. Además, el lupus cutáneo crónico es una o más placas, sin pústulas, de curso crónico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 62 6.01.1.012 · Granuloma piogénico

Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía: Foto 4 (http://sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com/2013/03/no-todas-las-lesiones-de-la- XXXXXX.html) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Verruga vulgar
B) Granuloma piógeno
C) Molusco contagioso
D) Melanoma amelanótico
E) Carcinoma basocelular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Granuloma piógeno** (opción **B**). Es un granuloma piógeno clásico. Eso sí, la foto era distinta.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 31 6.01.1.012 · Granuloma piogénico

Una paciente de 28 años, embarazada de 28 semanas, consulta por aparición de una lesión cutánea en el dedo medio, de algunas semanas de evolución, friable, que ha sangrado en varias oportunidades. Al examen físico, se observa la siguiente fotografía (fuente: sanchezcarpinterodermatologo.blogspot.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Verruga vulgar
B) Granuloma piógeno
C) Molusco contagioso
D) Melanoma amelanótico
E) Carcinoma basocelular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Granuloma piógeno** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 32 6.01.1.012 · Granuloma piogénico

Un adolescente de 14 años consulta por una lesión de color rojo, en el tórax, que apareció hace algunas semanas y que ha sangrado varias veces, en relación al roce de la ropa. Se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pioderma gangrenoso
B) Hemangioma infantil
C) Nevo atípico inflamatorio
D) Granuloma telangiectásico
E) Melanoma maligno

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Granuloma telangiectásico** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 83 6.01.1.028 · Tumores benignos de piel

Una paciente de 24 años presenta una cicatriz en la zona esternal de gran tamaño, secundaria a una cirugía torácica realizada hace 6 meses, que no ha respondido a la terapia compresiva. Al examen Fsico se observa una cicatriz que sobrepasa los bordes de la cirugía inicial, de aspecto rojo-violáceo y dolorosa a la palpación. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Cicatriz hipertrófica en fase ac2va
B) Queloide
C) Cuerpo extraño
D) Úlcera de Marjolin
E) Granuloma piógeno

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El hecho de sobrepasar los bordes de la herida es lo característico de los queloides. Un porcentaje importante puede tener dolor durante la fase de mayor acGvidad. El cuerpo extraño (ej. reacción a sutura) suele ser más localizado. La úlcera de Marjolin es un cáncer de piel que se origina en quemaduras y cicatrices grandes.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 64 6.01.1.028 · Tumores benignos de piel

Un paciente, de 17 años, consulta por aparición de un nódulo blanquecino, que apareció hace 3 semanas, en una zona donde se había puesto un arete y que ha ido aumentando de tamaño. El diagnóstico más probable es:

A) Dermatofibroma
B) Quiste dermoides
C) Neurofibroma
D) Dermatitis de contacto
E) Queloide

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Queloide** (opción **E**). Es un queloide clásico (cicatriz patológica, grande, que sobrepasa los límites de la herida).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 151 6.01.1.002 · Alopecías

Un paciente de 19 años consulta por caída de cabello en la zona occipital, que inició hace 2 semanas. Al examen físico, se aprecia una zona sin cabellos, tal como se muestra en la foto: Foto 15 (https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/XXXXXXX). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lupus eritematoso cutáneo crónico
B) Alopecia areata
C) Alopecia androgénica
D) Tricotilomanía
E) Tiña capitis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Alopecia areata** (opción **B**). Es una alopecia areata clásica.. La urticaria es una enfermedad muy frecuente caracterizada por la aparición de ronchas o habones que son lesiones eritematosas sobreelevadas de bordes bien definidos que desaparecen completamente a la presión digital y se resuelven espontáneamente en menos de veinticuatro horas sin dejar marca. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 137 6.01.2.003 · Erisipela / Celulitis

Una paciente de 62 años presenta una caída a nivel, con erosión en la rodilla derecha. Tres días después presenta una lesión eritematosa, que rodea la herida, de 10 cm de diámetro y bordes difusos, con aumento de la temperatura local. ¿Cuál es la conducta de elección?

A) Indicar mupirocina tópica
B) Realizar curación con suero fisiológico y control en 48 horas
C) Realizar curaciones diarias con suero fisiológico y povidona yodada
D) Indicar amoxicilina oral por 7 días
E) Indicar cefadroxilo oral por 7 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una celulitis. Se trata con antibióticos orales (solo si no tiene fiebre) o idealmente endovenosos, que cubran S. aureus (cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas de primera generación; en alérgicos a todos los betalactámicos: clindamicina).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 178 6.01.1.017 · Melanoma maligno

Una paciente de 26 años nota aparición de una lesión en el tercio medio de la pierna derecha, desde hace 6 meses, con crecimiento progresivo. Al examen físico se observa lo siguiente: Fuente: www.alamy.com El diagnóstico más probable es:

A) Nevo
B) Melanoma
C) Léntigo
D) Queratosis seborreica
E) Queratosis actínica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un melanoma clásico, tanto por la edad, como por el crecimiento. La imagen sí tiene un aspecto de queratosis seborreica, aunque el halo hiperpigmentado y la lesión satélite son más de melanoma.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 115 6.01.1.017 · Melanoma maligno

Paciente de 90 años con 3 lesiones pigmentadas de crecimiento progresivo en la pierna. La mayor se muestra en imagen. ¿Diagnóstico más probable?

A) Queratosis seborreica pigmentada
B) Melanoma con satelitosis
C) Carcinoma basocelular pigmentado
D) Nevo melanocítico displásico
E) Dermatofibroma pigmentado

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Melanoma con satelitosis** (opción **B**). Melanoma con satelitosis. El melanoma maligno es el tumor maligno de piel más mortal aunque no el más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 121 6.01.1.022 · Pitiriasis Rosada de Gilbe

Una mujer de 18 años presenta una placa eritematosa y levemente pruriginosa, de 5 cm, en la espalda, sin otros síntomas. Una semana después se agregan múltiples lesiones similares, de menor tamaño en todo el tronco. El diagnóstico más probable es:

A) Tiña
B) Lupus cutáneo subagudo
C) Sífilis secundaria
D) Pitiriasis versicolor
E) Pitiriasis rosada

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pitiriasis rosada de Gibert clásica, con la mancha heráldica y la posterior aparición del exantema rosado y descamativo. Puede o no tener prurito.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 116 6.01.2.009 · Herpes zoster

Adulto mayor con dolor en cuero cabelludo seguido de vesículas en esa zona. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Aciclovir tópico 5% en crema
B) Famciclovir 500 mg cada 8 horas por 7 días
C) Prednisona oral 40 mg/día por 5 días
D) Gabapentina 300 mg cada 8 horas
E) Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días** (opción **E**). Valaciclovir 1 g cada 8 horas vía oral por 7 días. Aspirina CONTRAINDICADA en varicela (síndrome de Reye). Tratamiento: paracetamol. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 158 6.01.2.009 · Herpes zoster

Una paciente de 76 años, diabética, consulta por un cuadro de 3 días de evolución de aparición de una lesión eritematosa en el tronco, asociada a dolor urente, como se ve en la siguiente imagen: El tratamiento más adecuado es:

A) Aciclovir 400 mg cada 8 horas, por 5 días
B) Valaciclovir 1g cada 8 horas, por 7 días
C) Aciclovir tópico
D) Loratadina 10 mg al día por 5 días
E) Flucloxacilina 500 mg cada 8 horas por 10 días

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El tratamiento del herpes zóster es con aciclovir 800 mg, 5 veces al día o con valaciclovir 1g c/8 horas, por un tiempo de 5 a 7 días. En cambio, los herpes simplex (genital o bucal) se tratan con la mitad de la dosis. Es muy raro que el Eunacom pregunte dosis de medicamentos, pero en esta pregunta era la única forma de elegir.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 170 6.01.2.009 · Herpes zoster

Un paciente de 37 años presenta dolor en el lado derecho de la cabeza, desde hace 2 días. El día de hoy aparecen lesiones en la piel, que se muestran a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Aciclovir 400 mg cada 6 horas, vía oral por 7 días
B) Fluloxacilina 500 mg cada 8 horas, vía oral por 7 días
C) Prednisona 40 mg al día, vía oral por 7 días
D) Mupirocina en crema al 1%, aplicar cada 8 horas, por 7 días
E) Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Valaciclovir 1 gramo vía oral cada 8 horas, por 7 días** (opción **E**). Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 42 6.01.3.003 · Manifestaciones cutáneas d

Un hombre de 92 años que hace un año nota aparición de 3 lesiones puntiformes en la pierna derecha, que han ido en aumento, en especial una de ellas, que ha alcanzado gran tamaño y que se muestra en la siguiente imagen (fuente: www.medigraphic.com/): ¿Cuál es diagnóstico más probable?

A) Melanoma con satelitosis
B) Pioderma gangrenoso
C) Carcinoma basocelular
D) Granuloma piógeno
E) Eccema numular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Pioderma gangrenoso** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 114 6.01.5.001 · Biopsia de piel

Adulto mayor con Alzheimer presenta lesiones ulceradas en la pierna de aspecto sospechoso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar antibiótico tópico y cubrir
B) Curación avanzada con alginato de calcio
C) Solicitar Doppler venoso de extremidades
D) Tomar biopsia de las lesiones
E) Derivar a dermatología en control habitual

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Tomar biopsia de las lesiones** (opción **D**). Tomar biopsia de las lesiones. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 14 6.01.1.016 · Lupus eritematoso cutáneo

Mujer de 35 años con placas eritematosas en cuero cabelludo con alopecia cicatricial, fotosensibilidad y presencia de tapones foliculares. Lesiones similares en mejillas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tinea capitis
B) Alopecia androgénica
C) Tricotilomanía
D) Lupus eritematoso discoide
E) Alopecia areata

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lupus discoide: placas eritematosas con escamas adherentes, tapones foliculares y alopecia cicatricial en cuero cabelludo + fotosensibilidad en mejillas. Alopecia cicatricial permanente. Tratamiento: antipalúdicos (cloroquina) + protección solar.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 2 6.01.1.016 · Lupus eritematoso cutáneo

Mujer 30 años con aparición de Placa eritematodescamativa de 2 meses de evolución en pómulo derecho de 3 cm de diámetro y otra similar en cuero cabelludo (zona parietal izquierda) con alopecia central.

A) Lupus cutáneo crónico
B) Dermatitis seborreica
C) Psoriasis
D) Liquen plano
E) Rosácea

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Lupus cutáneo crónico). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Dermatitis seborreica, Psoriasis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 113 6.01.1.014 · Linfomas cutáneos

Paciente con prurito, aumento grosor uñas en manos y pies, aumento volumen inguinal bilateral, foto de unas manos eritematosas, descamando:

A) Linfoma cutáneo (sd sezary)
B) Sarna noruega
C) Psoriasis
D) Dermatitis crónica
E) Dermatitis atópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Linfoma cutáneo (sd sezary)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Sarna noruega, Psoriasis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 104 6.01.1.025 · Reacciones cutáneas por dr

Un paciente de 29 años, tratado con amoxicilina por amigdalitis pultácea diagnosticada hace 14 días, presenta desde hace 3 días ardor en los ojos, lesiones en la boca, malestar general y aparición de un rash cutáneo. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral, úlceras orales y un exantema con pápulas y placas eritematosas en tronco y extremidades. La inspección facial muestra lo siguiente (fuente: prontopele.com.br): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Pénfigo
E) Escarlatina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome de Stevens-Johnson: El cuadro clínico presentado, junto con la imagen, son característicos del síndrome de Stevens-Johnson.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 125 6.01.1.013 · Hemangiomas cutáneos infan

Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Solicitar ecografía abdominal
B) Iniciar propranolol oral
C) Iniciar corticoides intralesionales
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hemangiomas Infantiles: La presencia de múltiples hemangiomas infantiles (≥5) obliga a descartar hemangiomas viscerales con una ecografía abdominal. El propranolol oral es el tratamiento de elección para los hemangiomas complicados o deformantes.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 78 6.01.1.001 · Acné

Un paciente de 17 años consulta por acné. Al examen Fsico se observan múl8ples comedones en cara, pecho y espalda, asociados a pápulas y pústulas abundantes, y presencia de algunos quistes en dichas zonas con cicatrices atróficas. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A) Peróxido de benzoilo tópico
B) Clindamicina tópica
C) Isotre2noína oral
D) Doxiciclina oral
E) Adapaleno tópico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un acné nódulo quístico, que se considera de Gpo inflamatorio severo. El acné comedoniano (leve) se trata con re<noides tópicos (ej. adapaleno o ácido reGnoico, también llamado treGnoína). El acné inflamatorio leve, recibe re<noides más an<micronbianos tópicos (peróxido de benzoílo o clindamicina). El acné inflamatorio severo requiere de tratamiento sistémico, generalmente con isotre<noína y antibióticos orales, generalmente tetraciclinas (doxicilina o minociclina). El conglobata y fúlminans, requieren cor<coides + an<bió<cos + isotre<noíana por vía oral.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 81 6.01.1.029 · Tumores premalignos (quera

Un paciente de 72 años, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en hemodiálisis, presenta aparición de una lesión en la cara anterior de la pierna derecha, eritematosa y descama8va, que inició hace cerca de 12 meses y ha ido aumentando progresivamente de tamaño. Al examen Fsico se observa la siguiente lesión: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Psoriasis
B) Derma22s de contacto
C) Eccema numular
D) Enfermedad de Bowen
E) Tiña

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien por la ubicación y aspecto se podía pensar en una psoriasis, la edad, la evolución y la presencia de una única lesión es característica de la enfermedad de Bowen, que es un cáncer espinocelular in situ. Fuente imagen: hxps://iqb.es/dermatologia.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 20 6.01.1.030 · Urticaria aguda

Mujer de 28 años con urticaria generalizada de 48h de evolución, prurito intenso. Sin angioedema ni compromiso hemodinámico. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Levocetirizina oral
B) Adrenalina subcutánea
C) Metilprednisolona EV
D) Omalizumab subcutáneo
E) Inmunoterapia sublingual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Urticaria aguda sin anafilaxia: antihistamínicos H1 de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, loratadina) son primera línea. Corticoides se reservan para casos refractarios.

PSIQUIATRÍA & SALUD MENTAL

Módulo 2: Cirugía y Especialidades · Colección Tomo 17

210 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

33 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
5.01.1.001	Trastorno de pánico con o sin agorafobia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	18 Q	Tomo 17 · C.2 (Pág. 8)
5.01.1.002	Trastorno obsesivo compulsivo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 17 · C.50 (Pág. 104)
5.01.1.003	Trastornos fóbicos (fobia social y fobia específica)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.004	Trastorno de adaptación	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	7 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.005	Trastorno agudo por estrés	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.006	Trastorno por estrés postraumático	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 17 · C.11 (Pág. 26)
5.01.1.007	Primer episodio depresivo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	18 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.008	Trastorno depresivo (recurrente)	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.009	Trastorno bipolar	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.010	Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	32 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.011	Consumo perjudicial de alcohol y drogas	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 17 · 17.16 (Pág. 60)
5.01.1.012	Dependencia de alcohol	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.013	Dependencia de otras drogas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.014	Delirium	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.016	Trastornos de la personalidad	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.017	Disfunción sexual	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.018	Trastornos de la conducta alimentaria	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.020	Trastornos somatomorfos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	10 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.021	Trastornos disociativos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.022	Trastornos facticios	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.023	Trastorno del espectro autista	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.028	Trastorno por déficit atencional	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.029	Intento de suicidio en niños y adolescentes	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.031	Trastorno conducta disocial	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
5.01.1.034	Trastornos del ánimo en niños	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.035	Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.1.036	Trastorno de ansiedad generalizada	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.2.002	Agitación psicomotora	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.2.003	Intoxicación por sustancias psicoactivas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.3.005	Higiene del sueño	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.3.011	Prevención: Alcohol, tabaco, drogas. Modelo de prevención primaria.	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.4.001	Estudio de hormonas tiroídeas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)
5.01.5.002	Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 17 · Psiquiatría (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 89 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Paciente de 28 años con miedo intenso y síntomas físicos ante situaciones de hablar en público o comer frente a otros. Evita reuniones sociales y ha rechazado ascensos laborales por esto. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea?

A) Escitalopram (ISRS)
B) Propranolol a demanda
C) Alprazolam a diario
D) Haloperidol
E) Carbamazepina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fobia social / trastorno de ansiedad social: el tratamiento farmacológico de primera línea son los ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina). Se combinan con TCC. El propranolol es para situaciones puntuales.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 123 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Un hombre de 21 años experimenta dificultades para realizar presentaciones en público, que han afectado su rendimiento académico. Además, refiere enrojecimiento facial y torpeza en situaciones sociales. Recientemente no pudo terminar una presentación oral frente a su curso, ya que refiere que su mente se quedó en blanco en un momento. Todo esto le ha generado angustia y tristeza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fobia específica
B) Agorafobia
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Trastorno de personalidad evitativa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fobia Social: El cuadro clínico presentado describe una fobia social, también llamada trastorno de ansiedad social.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 44 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Paciente masculino de 27 años de edad , quien presenta desde hace 1 año temor a volar, por lo que prefiere desplazarse por tierra siempre. Incluso ha dejado de asistir a congresos y visitar a familiares en el extranjero. Siente mucha angustia y palpitaciones, cada vez que sabe que debe tomar un avión, desde los días antes y en dos oportunidades, previo a los vuelos, ha tomado benzodiacepinas con respuesta parcial. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Fobia especifica
C) Agorafobia
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno por ansiedad de separación

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fobia especifica** (opción **B**). Es una aerofobia, que es la fobia específica a volar.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 129 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Una mujer de 34 años se siente muy ansiosa al realizar actividades como hacer presentaciones o hablar en reuniones de trabajo. Por ello evita ese tipo de situaciones y asigna dichas tareas a sus subalternos, sobrecargándolos. Incluso dejó de asistir a un congreso de ejecutivos, en el que tendría que exponer. El diagnóstico más probable es:

A) Fobia social
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de personalidad antisocial
D) Trastorno de personalidad evitativo
E) Trastorno de pánico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Fobia social** (opción **A**). Es una fobia social clásica: ansiedad al realizar actividades en público y evitación de las mismas.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 82 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Una paciente de 20 años presenta mucha ansiedad ante las situaciones en que debe hacer exposiciones o presentaciones ante los demás. Presenta sudoración y palpitaciones antes de las presentaciones, con opresión cordial y disnea y esta dispuesta incluso a aumentar su carga de trabajo, con tal de evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno de personalidad evitativo
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Trastorno de angustia
E) Trastorno de ansiedad social

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La opción correcta es la **E** (Trastorno de ansiedad social). En este escenario clínico, trastorno de ansiedad social se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 9 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Un paciente de 24 años, estudiante de derecho, debe rendir su examen oral final para obtener su título profesional, ha estudiado por varios meses y tiene buen dominio de los temas, pero a pesar de que se ha preparado, no ha querido presentar aún el examen, ya que según él “no puedo hacerlo”. Refiere que le ha pasado lo mismo en situaciones similares donde le ha tocado exponer presentando gran nerviosismo. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de pánico
B) Trastorno de la personalidad evitativo
C) Ansiedad social
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Agorafobia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Ansiedad social** (opción **C**). Es una fobia social de libro.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 106 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Un paciente de 21 años no sale de su casa por miedo a encontrarse con alguien que conozca y que le haga preguntas sobre su vida. Incluso desconecta el teléfono, para evitar que sus familiares lo llamen y le hagan preguntas. Se siente muy incómodo por lo que pudieran pensar de él las demás personas. Desde el colegio era muy tímido, pero esto empeoró al entrar a estudiar sus estudios superiores y actualmente afecta significativamente su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Depresión psicótica
B) Trastorno de ansiedad social
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Esquizofrenia
E) Trastorno delirante crónico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Esta estaba más difícil, pero sigue siendo una buena pregunta. En mi opinión era una fobia social generalizada y bastante grave. Tal vez tenía de base un trastorno de personalidad evitativo además, pero no aparecía en las alternativas.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 35 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Una paciente de 20 años, universitaria, tiene escasa interacción con sus compañeros, porque la inhibe el juicio que ellos puedan tener sobre su desempeño. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de personalidad esquizoide
B) Trastorno de ansiedad
C) Fobia social
D) Trastorno del espectro autista
E) Esquizofrenia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parecía que además tenía un T. de personalidad evitativo, pero en esta pregunta no estaba en las opciones. Además, que la ansiedad la genere el juicio de los demás, es lo clásico de la fobia social.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 156 5.01.1.003 · Trastornos fóbicos (fobia

Estudiante 4to año medicina, con miedo hablar en público y quedarse en blanco- a. Fobia social

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno bipolar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Trastorno de ansiedad generalizada). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Trastorno obsesivo compulsivo, Trastorno de estrés postraumático) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 137 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 26 años, estudiante universitario con regular rendimiento, es traído por sus padres porque desde hace tres meses no ha asistido a clases, ya que prefiere quedarse en su habitación. Ellos refieren que siempre fue solitario y que no buscaba tener amistades. Al entrevistarlo de forma dirigida se ríe sin motivo y refiere que no quiere salir de su habitación porque la voz del diablo lo amenaza. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno delirante crónico
B) Trastorno de la personalidad esquizoide
C) Delirium
D) Esquizofrenia hebefrénica
E) Trastorno Bipolar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Esquizofrenia hebefrénica** (opción **D**). La risa sin motivo orienta a Hebefrenia. El cuadro clínico es sugerente de EQZ.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 90 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 35 años está convencido que las vacunas contra la Covid-19 contienen un chip para rastrear a las personas y que hay un acuerdo entre Bill Gates y muchos de los gobiernos para controlar las mentes de la población, tal como lo ha hecho con muchas personas, a las que califica de “borregos”. Cree que la mayoría de los médicos son parte de este complot, porque están financiados por las farmacéuticas y el Gobierno. Si bien se desenvuelve normalmente en su trabajo, ha tenido varios problemas con compañeros de trabajo y con sus familiares, cuando se toca el tema de las vacunas, en el que habla con gran vehemencia y certeza, criticando duramente a quienes le recomiendan vacunarse. También pierde mucho tiempo discutiendo sobre el tema en redes sociales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante
C) Trastorno del espectro autista en el adulto
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de personalidad paranoide (Nota: pregunta añadida a la reconstrucción) RECONSTRUCCIÓN EUNACOM AGOSTO 2021 Dr. Guillermo Guevara Aliaga SEGUNDA PARTE Instrucciones:

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un TDC clásico, con un delirio sistematizado y afectación únicamente en esa área. Si bien es relativamente joven, no tiene alucinaciones ni síntomas negativos o primarios de esquizofrenia.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 116 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 21 años, abandonó a los 18 años su hogar, viviendo solo en la calle. Tiene la idea de ser un enviado de Dios, con la misión de salvar al mundo y dice que los ángeles le susurran al oído diciéndole cómo hacerlo. Los familiares refieren que empezó hace 3 años con esto y que no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno delirante crónico
B) Esquizofrenia
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno de personalidad esquizoide
E) Trastorno de conducta

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Esquizofrenia** (opción **B**). Es una EQZ clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 129 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un hombre de 18 años tiene la idea de que algunas personas quieren dañarlo. Pre- viamente a esto presentaba retraimiento social. En el último tiempo el cuadro empeora, agregándose alucinaciones de voces, que lo insultan y ha descuidado significativamente su higiene personal. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Personalidad esquizotípica
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno esquizoafectivo
E) Depresión psicótica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Esquizofrenia** (opción **A**). Es una esquizofrenia clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 76 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una paciente de 40 años, trabajadora de supermercado, consulta por sen8rse angus8ada y triste. Refiere que desde su adolescencia presenta alucinaciones audi8vas, consistentes en voces que hacen comentarios nega8vos acerca de ella, las que desaparecen durante algunos periodos, reapareciendo en momentos de mayor estrés o soledad. Refiere que en el úl8mo 8empo las voces le han estado ordenando que se suicide. Al examen Fsico destaca su aspecto personal muy descuidado. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Trastorno delirante crónico
B) Delirium
C) Esquizofrenia
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Depresión mayor con síntomas psicó2cos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una esquizofrenia clásica, con alucinaciones auditivas, inicio en la adolescencia y afectación general de su vida (aspecto descuidado), que en este caso está complicada con una probable depresión y síntomas ansiosos. No parece un trastorno esquizoafectivo (no está dentro de las opciones), ya que no Gene historia de episodios depresivos y/o maníacos a repeGción.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 39 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Joven de 22 años que abandonó su carrera universitaria hace 8 meses, pasa la mayor parte del tiempo en casa, habla solo, ríe sin motivo aparente y cree que sus compañeros lo persiguen. Sin consumo de sustancias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno esquizoafectivo
C) Trastorno de personalidad esquizoide
D) Trastorno bipolar con psicosis
E) Trastorno delirante crónico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Esquizofrenia: síntomas positivos (alucinaciones, ideas de persecución) + negativos (aislamiento social, abandono de actividades) + desorganización (habla solo, risa inapropiada) por >6 meses en adulto joven. Requiere antipsicótico + rehabilitación.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 95 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una paciente de 42 años, que 2 meses después de un quiebre conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio de persecución y alucinaciones auditivas, asociado a marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Depresión psicótica
B) Trastorno adaptativo mixto
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Esquizofrenia
E) Trastorno esquizoide

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene clara coexistencia de síntomas psicóticos (alucinaciones y delirio) con síntomas anímicos depresivos, por lo que es un T. esquizoafectivo clásico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 39 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 52 años presenta un cuadro de alucinaciones auditivas, desde la adolescencia. En el último tiempo, las alucinaciones se intensifican, escuchando voces que la insultaban y le decían que se suicidara. Está muy angustiada y se ha sentido triste por lo que le sucede. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante crónico
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno depresivo mayor
E) Trastorno esquizotípico de la personalidad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Esquizofrenia** (opción **A**). Parece una esquizofrenia por las alucinaciones auditivas y el inicio en la adolescencia.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 172 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente masculino, de 22 años, desde hace más de 6 meses ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidando su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ezquizofrenia
B) Depresión psicótica
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad esquizoide
E) Trastorno bipolar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una forma clásica del primer brote de esquizofrenia. La edad es compatible. Seguramente tiene alucinaciones auditivas y por eso habla y se ríe solo.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 75 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 24 años tiene la idea de que es el enviado de Dios y que está encargado de la salvación de las almas. Se muestra convencido de ello y al confrontarlo con la realidad, reacciona algo agresivo. Es un paciente tranquilo, con pocos amigos y afectivamente plano. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno esquizoafectivo
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad narcisista
E) Esquizofrenia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Esquizofrenia** (opción **E**). Tiene síntomas positivos (delirio megalomaniaco) y negativos (aplanamiento afectivo). Es una Esquizofrenia. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 51 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Paciente joven de 24 años, es traído por sus padres ya que desde hace aproximadamente un año se vuelve muy solitario, no sale de su hogar, descuida su higiene y habla frecuentemente sobre el apocalipsis y el fin de la humanidad. Al entrevistarlo se aprecia con marcado aplanamiento afectivo y frente a distintas preguntas habla sobre el apocalipsis. Su madre está actualmente cursando con depresión y su padre tiene trastorno bipolar en tratamiento con litio. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno por abuso de sustancias
C) Trastorno de la personalidad esquizotípico
D) Esquizofrenia
E) Trastorno delirante crónico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una familia muy disfuncional. La clínica orienta mucho a EQZ. Los antecedentes familiares confunden, porque orientan a T. bipolar, pero no hay clínica de dicha enfermedad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 71 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una paciente de 46 años presenta conflictos frecuentes con dis8ntas administraciones de su edificio, que se han extendido durante los úl8mos 10 años, y que ella atribuye al hecho de que vive sola y que, durante su jornada laboral, los conserjes y el personal del edificio aprovechan su ausencia para entrar a su departamento y u8lizarlo como lugar de alimentación y para dormir y descansar en él sin su autorización. Comenta que las cámaras del edificio no han logrado captar estos hechos debido a la probable u8lización de algún 8po de inhibidor de señal. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Esquizofrenia
B) Depresión con síntomas psicó2cos
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno de personalidad esquizoide

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un delirio, que es un conjunto de ideas fuera de la realidad de naturaleza apodíctica (verdad absoluta), sistemaGzado (bien explicado) y crónico (mayor a 3 meses), por lo que es un trastorno delirante crónico clásico. No es trastorno de personalidad paranoide, ya que está psicótica y, en cambio, el trastorno de personalidad paranoide es una persona muy desconfiada y celosa, pero sin pérdida de juicio de realidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 135 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Paciente con trabajo y buenas relaciones, pero cree que sus vecinos entran a su casa mientras ella no está. ¿Diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia paranoide
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno bipolar con síntomas psicóticos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno delirante** (opción **B**). Trastorno delirante. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 69 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 84 años consulta por un cuadro de 4 semanas de evolución de des- confianza, asociada a enojo porque quienes viven con él le roban y le cambian sus co- sas de lugar, para molestarlo. Hace 1 semana despidió a alguien que había trabajado por 30 años con él, por la misma razón. Al examen se muestra molesto respecto al tema, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Demencia
B) Paranoia
C) Delirium
D) Trastorno delirante
E) Depresión psicótica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cumple criterios de trastorno delirante, con delirio de persecución. No se indicaba desorientación ni inatención, como para pensar en delirium; tampoco había síntomas anímicos, como para pensar en depresión. La memoria no estaba afectada, como para pensar en demencia. No es un trastorno delirante crónico (mayor a 3 meses).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 95 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una paciente de 81 años, hace un año tiene la idea de padecer de VIH, por lo que se ha realizado múltiples exámenes, los que siempre han resultado negativo. A pesar de ello, ella continúa con la idea. Fuera de esto, su vida no ha sido mayormente afectada. El diagnóstico más probable es:

A) Demencia
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno delirante crónica
D) Trastorno por hipocondría
E) Depresión psicótica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno delirante crónica** (opción **C**). Es un TDC clásico, con delirio de enfermedad.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 78 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un hombre de 25 años, con antecedente de esquizofrenia, con mala adherencia al tratamiento oral, inicia tratamiento con flufenazina intramuscular de depósito hace 3 días. Sin embargo, comienza con un cuadro de inquietud, malestar general y fiebre hasta 38,7°C, seguido de obnubilación. Al examen físico tiene FC: 109x', PA: 150/102 mmHg, T°: 38,5°C y, en el examen segmentario, destaca rigidez muscular generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Meningitis bacteriana
B) Distonía aguda
C) Infección en el sitio de punción
D) Síndrome serotoninérgico
E) Síndrome neuroléptico maligno

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Distonía aguda** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Meningitis bacteriana, Infección en el sitio de punción) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 91 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una niña de 15 años ha presentado una serie de conflictos con sus familiares en el último tiempo, discutiendo con varios de ellos, de manera intensa. Además, está muy conversadora, incluso con extraños y ha tenido varios problemas en el colegio, debido a que interrumpe reiteradamente las clases y, cuando sus profesores la han hecho callar, responde de forma agresiva y los insulta. Duerme cerca de 5 horas al día, inició su vida sexual recientemente, sin protección y ha consumido marihuana en 3 oportunidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional hiperactivo
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Esquizofrenia
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno por consumo de sustancias

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Esquizofrenia** (opción **C**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Trastorno por déficit atencional hiperactivo, Trastorno de personalidad limítrofe) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 83 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una paciente de 64 años ha presentado, desde hace algún tiempo, conflictos con sus vecinos. Refiere que varios de sus vecinos tienen intenciones de dañarla o perjudicarla de alguna forma. Además, refiere la certeza de que sus vecinos han entrado a su departamento, habiéndose sentado en sus sillones, fumado en su sala e incluso dormido en su cama. Tiene una red de apoyo funcional, con buenas relaciones con sus familiares, quienes se muestran preocupados con este tema. No tiene otros síntomas y su examen de Minimental resulta 29/30. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno delirante
B) Depresión con síntomas psicótico
C) Esquizofrenia de inicio tardío
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno esquiafectivo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Depresión con síntomas psicótico** (opción **B**). Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 108 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 54 años está seguro de que su esposa lo engaña, lo que confirma con un cambio de actitud que ella ha tenido en el último tiempo. Además cree saber con quién lo engaña, ya que se ha encontrado con el sujeto en la calle y siempre mira para abajo. La esposa y los familiares niegan los hechos, pero están preocupados por lo que pasa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad esquizoide
B) Esquizofrenia
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno delirante crónico
E) Trastorno bipolar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno delirante crónico** (opción **D**). Tiene un clásico TDC, con delirio de celos.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 76 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 56 años dice, desde hace algunos meses, que sus vecinos lo espían y que están conspirando contra él. No tiene otros problemas y tiene una vida laboral y familiar normales. La esposa se muestra muy preocupada y refiere además que el paciente es aceptado y querido por todos y que los vecinos nunca lo han espiado ni nada similar. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Depresión
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno delirante crónico** (opción **C**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 171 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un hombre de 50 años asegura que es constantemente espiado por los gobiernos de varios países, dado que el maneja información importante y confidencial de muchos políticos y personas de poder. Al preguntarle cómo sabe que lo espían, reacciona enojado diciendo que es obvio y que uno de sus vecinos fue quien inició todo esto. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno esquizoide de la personalidad
E) Trastorno paranoide de la personalidad

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un delirio paranoide, con la reacción apodíptica clásica de alguien psicótico. La edad y la ausencia de alucinaciones y síntomas negativos hacen improbable una esquizofrenia. No tiene síntomas anímicos, como para pensar en T. esquizoafectivo. Los T. personalidad no están psicóticos, aunque el TP paranoide es muy celoso y desconfiado y el TP esquizoide es muy solitario, apático e indiferente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 83 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un hombre de 46 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos y al interrogar a sus compañeras de trabajo, lo niegan. Al confrontar al paciente, se enoja, ya que le molesta que no crean en lo que él dice. El diagnóstico más probable es:

A) Hipomanía
B) Esquizofrenia
C) Trastorno delirante crónico
D) Dismorfofobia
E) Trastorno de personalidad narcisista

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno delirante crónico** (opción **C**). Es un trastorno delirante crónico de libro (delirio sistematizado; pérdida de juicio de realidad).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 74 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 18 años presenta un cuadro de ánimo bajo, en tratamiento con antidepresivos por 3 meses, sin respuesta. Sus padres están muy preocupados, porque permanece encerrado en su cuarto, sin hacer nada, ni siquiera ver televisión. Al examinarlo, no se aprecia anhedonia, ni tristeza. No ha tenido alucinaciones. El diagnóstico más probable es:

A) Distimia
B) Trastorno de personalidad esquizoide
C) Esquizofrenia
D) Trastorno esquizoafectivo
E) Depresión mayor

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Aunque no tenga ni un delirio, ni alucinaciones, parace una esquizofrenia, que está debutando. Probablemente una esquizofrenia simple o también puede ser catatónica (por permanecer inmóvil tanto tiempo).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 17 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una mujer de 35 años, sin antecedentes, consulta porque está segura de que todos sus compañeros de trabajo la seducen y la acosan, esto le ocurre desde hace aproximadamente 10 años y le ha traído problemas en su trabajo, por lo que ha sido despedida en otros trabajos. No refiere presentar problemas en otros ámbitos de su vida, tiene buena relación con familiares y amigos. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de personalidad paranoide
B) Trastorno de personalidad histriónico
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de la personalidad esquizotípico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien parece histriónica, ha perdido el juicio de realidad y además "está segura", por lo que es un TDC.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 109 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una paciente de 58 años ha tenido gran conflicto con la comunidad del edificio en que vive y también con la administración. Además, se la ha visto vociferando en los pasillos. Ella refiere que existe una asociación ilícita para explotar personas, en la que estarían involucrados el conserje, el administrador y varios de los copropietarios del edificio. Fuera de eso, no hay mayor afectación y se desenvuelve normalmente en su trabajo. Los familiares niegan las acusaciones. Al ser consultada dirigidamente, ella refiere el antecedente de consumir marihuana alrededor de una vez al mes. El diagnóstico más probable es:

A) Depresión psicótica
B) Trastorno delirante crónico
C) Esquizofrenia
D) Psicosis inducida por drogas
E) Trastorno bipolar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno delirante crónico** (opción **B**). Tiene un TDC, con delirio paranoide.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 110 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Una paciente de 42 años, que 2 meses después de una separación conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio paranoide y alucinaciones auditivas. Además presenta marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Depresión psicótica
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Esquizofrenia
E) Trastorno esquizoide de la personalidad

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

A, B?. Esta está muy difícil, ya que en la práctica misma es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial en los casos en que hay una clara mezcla de síntomas anímicos (tristeza, etc.) y psicóticos (delirio y alucinaciones). Sin embargo, me parece un trastorno esquizoafectivo, por la falta de predominancia de uno de estos tipos de síntomas y porque no daban un perfil temporal, en que hubiese iniciado con un tipo de síntomas y luego se hubiesen agregado los otros.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 129 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un hombre de 23 años consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución de ánimo expansivo, irritabilidad, verborrea y disminución de las necesidades de sueño, más un delirio de perjuicio. En los últimos 2 años, ha sido hospitalizado en 5 oportunidades, por episodios psicóticos, relacionados con suspensión del tratamiento. En ese tiempo presentó un episodio delirante, aún sin síntomas anímicos. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno esquizoafectivo
C) Esquizofrenia
D) Trastorno delirante crónico
E) Trastorno esquizotípico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene síntomas anímicos y psicóticos. Además, por la severidad del cuadro y haber tenido síntomas psicóticos sin compromiso anímico, es más probable que tenga un trastorno esquizoafectivo, en la variante bipolar.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 109 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Paciente en tratamiento con flufenazina, presenta alteración de conciencia, fiebre, rigidez de extremidades y taquicardia. ¿Diagnóstico más probable?

A) Hipertermia maligna anestésica
B) Síndrome serotoninérgico
C) Crisis distónica aguda
D) Síndrome neuroléptico maligno
E) Encefalitis autoinmune

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome neuroléptico maligno** (opción **D**). Síndrome neuroléptico maligno. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 36 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente esquizofrénico inicia tratamiento con risperidona oral y evoluciona con intranquilidad, especialmente de las extremidades inferiores, disestesias en las piernas y angustia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Distonía aguda
B) Acatisia
C) Hipomanía
D) Disquinesia tardía
E) Parkinsonismo farmacológico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Acatisia** (opción **B**). Es una acatisia clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 62 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un joven 17 años, comienza tratamiento con risperidona 3mg al día, hace 1 semana, por esquizofrenia primer brote. Presenta contracción cervical, mantenida y recurrente, que se acompaña de dolor. El diagnóstico más probable es:

A) Distonía aguda
B) Disquinesia tardía
C) Acatisia
D) Trastorno conversivo
E) Parkinsonismo por drogas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una distonía aguda clásica (contractura muscular tónica). La disquinesia tardía aparece años después y tiene movimientos reptantes de la boca, lengua y luego de extremidades. La acatisia es un cuadro de inquietud psicomotora y cambios continuos de posición.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 13 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente esquizofrénico, recién diagnosticado, inicia tratamiento con risperidona 2 mg/día hace 5 días. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a angustia, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de adaptación
B) Distonía aguda
C) Disquinesia aguda
D) Acatisia
E) Hipomanía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Acatisia** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Trastorno de adaptación, Distonía aguda) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 38 5.01.1.010 · Esquizofrenia y otros tras

Un paciente de 18 años, adicto a la pasta base, presenta un episodio psicótico, en relación al consumo, el que es manejado con haloperidol intramuscular. Al día siguiente presenta contracción tónica del cuello, que desvía la cabeza hacia la izquierda, con intenso dolor. El diagnóstico más probable es:

A) Distonía aguda
B) Acatisia
C) Síndrome neuroléptico maligno
D) Disquinesia tardía
E) Parkinsonismo farmacológico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Distonía aguda** (opción **A**). Es una distonía clásica: la tortícolis espasmódica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 59 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Una mujer de 18 años sufrió un rapto al salir de la oficina, por dos desconocidos. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente, sin lesiones físicas. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de lo sucedido, recordando solo cuando fue abordada por los desconocidos y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Trastorno facticio
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno disociativo** (opción **E**). Es una amnesia disociativa clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 114 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Una mujer de 18 años subió a un taxi, en el que el taxista se desvió del camino que debía tomar, siendo luego agredida por él. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de los sucedido, recordando solo cuando estaba en el taxi y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Trastorno facticio
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno disociativo** (opción **E**). Es una amnesia disociativa clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 12 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Una paciente de 59 años, luego de una pelea con su marido, se va de su casa y es en- contrada varias horas después sin recordar lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno facticio
B) Trastorno disociativo
C) Trastorno somatomorfo
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno adaptativo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno disociativo** (opción **B**). Es una fuga disociativa clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 180 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Una paciente de 23 años no llega a su domicilio luego de un conflicto familiar grave, siendo encontrada dos días después en una ciudad diferente, en buenas condiciones generales. Ella no recuerda nada de lo sucedido en ese intervalo de 8empo y no parece estar preocupada por ello. Su examen neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Amnesia global transitoria
B) Episodio psicó2co breve
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno de estrés agudo
E) Trastorno disocia2vo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una fuga disociativa clásica, que es un Gpo de amnesia disociativa, en la que, además, se produce una “fuga” desde su lugar habitual. No se debe confundir con la amnesia global transitoria, que es un Gpo de accidente isquémico transitorio cerebral (se debe buscar fuente embólica), que se caracteriza por desorientación y amnesia (repiGendo las mismas preguntas), autolimitado, de pocas horas de evolución.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 130 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Una paciente de 25 años fue encontrada vagando por la calle descalza, desorientada y confusa. Hace 5 horas había tenido una discusión con su padre, luego de lo cual salió de su casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disociativo
B) Trastorno adaptativo
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno somatomorfo
E) Trastorno facticio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno disociativo** (opción **A**). Es una fuga disociativa clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 26 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Una paciente de 40 años, con antecedente de cuatro episodios depresivos tratados y usuaria de fluoxetina de forma permanente, cursa un nuevo episodio luego de separación con su marido. En su último control se encontraba de mejor ánimo ya que asistiría al casamiento de su hija. Actualmente consulta muy preocupada porque hace aproximadamente una semana atrás, su mano derecha intentó atacarla, pero se defendió con la su mano izquierda y ayuda de familiares. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno delirante
C) Psicosis
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno por somatización

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hizo un trastorno disociativo grave, con despersonalización parcial. Es una pregunta muy difícil, ya que no es el cuadro clásico.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 107 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Un paciente es despedido de su trabajo, luego de ser sorprendido robando. Evoluciona con paresia de ambas manos. Al examen neurológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno de somatización
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno conversivo** (opción **A**). Es un trastorno conversivo clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 69 5.01.1.021 · Trastornos disociativos

Una mujer de 40 años pierde súbitame la movilidad de ambos brazos. Esto sucede en relación a la reactivación de un conficto familiar. Al examen físico se aprecia una disociación con los síntomas, por lo que se descarta patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno adaptativo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno conversivo** (opción **C**). Cuadro clásico (síntomas neurológicos de inicio súbito). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 174 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por ánimo bajo, anhedonia, insomnio de conciliación y despertar precoz. Además, ha aumentado de peso y tiene pensamientos negativos e ideas recurrentes negativas sobre sí mismo, sin ideación suicida actual. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento en este paciente?

A) Alprazolam
B) Sertralina
C) Quetiapina
D) Carbonato de litio
E) Amitriptilina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Depresión: La depresión se trata preferentemente con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como la sertralina. La depresión atípica, por otro lado, presenta síntomas como aumento de peso e hipersomnia y tradicionalmente se trataba con inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) como la fenelzina, pero, en la actualidad, los ISRS también se recomiendan como tratamiento de primera línea para la depresión atípica. En este caso es típica, al haber insomnio, en lugar de hipersomnia.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 174 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Un paciente de 40 años, sin antecedentes, con cuadro de disforia y anhedonia desde hace tres semanas, momento en el cual fue despedido de su trabajo, además presenta apetito disminuido, baja de peso e insomnio. Al entrevistarlo de forma dirigida refiere que siente que no vale nada y no ha presentado intentos ni ideas suicidas. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Venlafaxina
B) Amitriptilina
C) Clonazepam
D) Escitalopram
E) Bupropion

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Escitalopram** (opción **D**). Tiene una depresión: preferir ISRS. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 75 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Un paciente de 25 años presenta tristeza, dificultades en su trabajo, sensación de culpa patológica e insomnio de conciliación y mantención, de seis semanas de evolución, por lo que inicia tratamiento con escitalopram 10 mg al día. Tres semanas después, refiere que su ánimo ha mejorado considerablemente y que ya no se siente triste ni culpable y que tampoco ha seguido con problemas para dormir. Comenta sen8rse bien, similar a como estaba antes del inicio de estos síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender el tratamiento
B) Disminuir la dosis de citalopram
C) Mantener el tratamiento por 3 meses
D) Mantener el tratamiento por 12 meses
E) Cambiar el tratamiento a fluoxe2na

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil, ya que el tratamiento farmacológico de la depresión se deben mantener por 6 meses después de la remisión completa de los síntomas. De las opciones la única aceptable es 12 meses, Gempo que es aceptado por algunas fuentes.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 39 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Un paciente de 16 años, sin antecedentes mórbidos, es traído por presentar mal rendimiento escolar y mala relación con sus padres. Sus padres refieren que esto comenzó hace tres meses, que ha estado irritable, se alimenta mal y duerme poco. Al entrevistar solo al paciente, refiere que hace aproximadamente tres meses terminó una relación amorosa que fue muy importante. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno ansioso
B) Esquizofrenia
C) Trastorno delirante
D) Distimia
E) Depresión

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Depresión** (opción **E**). De libro. Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 158 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Una paciente de 34 años consulta por un cuadro de 6 semanas de evolución de ánimo bajo y tristeza, asociado a alza de peso y dificultades para dormir consistentes en insomnio de conciliación. Además, se ha sen8do más desconcentrada de lo habitual, con pensamientos nega8vos sobre sí misma, sin ideación suicida. ¿Qué fármaco es de elección para iniciar el tratamiento en esta paciente?

A) Bupropión
B) Citalopram
C) Venlafaxina
D) Mirtazapina
E) Carbonato de li2o

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El tratamiento de elección en la depresión son los antidepresivos IRS (inhibidores de la recaptura de serotonina), tales como sertralina, fluoxeGna, citalopram y escitalopram. De segunda línea (en caso de que no responda después de 4 semanas), se puede subir la dosis o idealmente cambiar a un antidepresivo dual, como la venlafaxina, duloxeGna, bupropión o mirtazapina. Los dos úlGmos, además, son úGles en casos en que los otros antidepresivos produzcan disminución de la libido.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 99 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Mujer de 30 años, 3 semanas post parto vaginal, consulta por llanto fácil, tristeza, insomnio, sentimiento de incompetencia como madre y pensamientos de hacerse daño. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A) Depresión postparto: iniciar antidepresivo (sertralina) + psicoterapia
B) Blues postparto: tranquilizar, resolverá espontáneamente en días
C) Psicosis puerperal: hospitalización de urgencia
D) Trastorno adaptativo: solo psicoterapia
E) Trastorno bipolar postparto: iniciar litio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Depresión postparto: debut >2 semanas posparto, síntomas depresivos + pensamientos de autolesión. Tratamiento: sertralina (segura en lactancia) + psicoterapia. Blues se resuelve en 2 semanas sin tratamiento.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 130 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Una paciente de 50 años presenta un cuadro de 5 meses de evolución de dificultades para concentrarse, asociadas a desgano, ánimo bajo y tristeza, síntomas que se acentúan en el periodo premenstrual. Sale muy poco de su casa y ha disminuido la interacción con otras personas, comentando que disfruta poco o nada con las actividades que habitualmente le eran placenteras. Refiere que duerme cerca de 2 horas menos que antes y que ha subido una talla de ropa. Sus exámenes generales descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno adaptativo
B) Episodio depresivo mayor
C) Trastorno de angustia generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Trastorno disfórico premenstrual

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una depresión clara con ánimo bajo, anhedonia, desconcentración, alteraciones del peso y del sueño.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 170 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Una paciente de 32 años consulta por un cuado de un mes de evolución, en que sale poco de su casa y presenta desgano y retraimiento social, disminuyendo el disfrute de las actividades que habitualmente le eran placenteras. También refiere desconcentración en su trabajo y, además, ha disminuido la cantidad del tiempo de sueño, en alrededor de 2 horas diarias. Refiere que los síntomas empeoran en el período premenstrual. El diagnóstico más probable es:

A) Episodio depresivo mayor
B) Trastorno adaptativo
C) Hipomanía
D) Trastorno esquizoafectivo
E) Trastorno disfórico premenstrual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una depresión clásica con anhedonia y afectación de distintas áreas de la vida (sueño, actividad social, concentración, etc.). Que empeore en el periodo premenstrual es algo que puede ocurrir con cualquier patología psiquiátrica y también con cualquier problema normal, sin necesariamente ser un síndrome premenstrual.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 49 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Una paciente de 43 años presenta ánimo bajo, desde hace 3 meses, asociado a llanto y a baja de peso de 8 kilogramos, desde ese entonces. Refiere que ya no disfruta de las cosas de la vida. Hace 2 semanas presenta alucinaciones auditivas, que ella identifica como una voz masculina que emite comentarios negativos sobre su situación. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno delirante crónico
C) Depresión con síntomas psicóticos
D) Trastorno esquizoafectivo
E) Trastorno esquizotípico de la personalidad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por tener muchos síntomas anímicos de larga data, a los que luego se agrega el síntoma psicótico, lo más probable es que sea una depresión psicótica (al menos en la forma en que está redactada en esta pregunta). Sin embargo, vale la pena mencionar que las alucinaciones auditivas sugieren mucho más un T. esquizoafectivo que una depresión psicótica (que suele tener un delirio de ruina o de culpa). Una pregunta muy similar, además, decía que tenía un tío con litio (se asumía bipolar) y que había tenido una psicosis postparto ella, caso en el cual la respuesta cambia, sin duda, a T. esquizoafectivo.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 129 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Un paciente de 62 años, con antecedente de síndrome metabólico e hipertensión arterial mal controlada, consulta por ánimo depresivo marcado, asociado a baja de peso, anhedonia e insomnio de dos meses de evolución. El tratamiento de primera línea es

A) Mirtazapina
B) Escitalopram
C) Venlafaxina
D) Amitriptilina
E) Imipramina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El tratamiento de elección de la depresión es con antidepresivos IRS, dentro de los que está el escitalopram. A y C son antidepresivos duales, que sirven como tratamiento de segunda línea. D y E son antidepresivos tricíclicos, que actualmente ya no se usan para el manejo de la depresión, por sus múltiples efectos adversos, sino que se usan como moduladores del dolor, en enfermedades dolorosas crónicas o neuropáticas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 120 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Un paciente de 82 años, sano, presenta un cuadro de desgano, desesperanza y ánimo bajo de algunos meses de evolución. Ha bajado 4 kilogramos de peso y sale muy poco de su casa, ya que no siente ganas de hacer nada y no disfruta de las cosas que habitualmente le gustaba hacer. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A) Paroxetina
B) Sertralina
C) Duloxetina
D) Amitriptilina
E) Clonazepam

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La depresión en el adulto mayor se trata con IRS, en especial la sertralina y el citalopram/escitalopram.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 63 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Un paciente de 70 años consulta por anhedonia, marcada angustia y desconcentra- ción de 2 meses de evolución, asociada a insomnio de conciliación y de despertar pre- coz y baja de peso de 5 kilogramos. No presenta alteraciones del pensamiento, ni del examen neurológico ¿Cuál es el tratamiento de elección para iniciar el tratamiento en este paciente?

A) Trazodona
B) Mirtazapina
C) Venlafaxina
D) Fluoxetina
E) Amitriptilina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Fluoxetina** (opción **D**). Es una depresión en el adulto mayor. Se trata con inhibidores de la recaptura de serotonina.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 61 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Paciente de 75 años, con cuadro de disforia y anhedonia desde hace un mes, asociado a fatigabilidad, disminución de peso e insomnio, además ha presentado fallas reiteradas de memoria. Su examen físico normal, se solicita TSH que resulta en 5,4. El tratamiento más adecuado en este paciente es:

A) Venlafaxina
B) Fluoxetina
C) Levotiroxina
D) Memantina
E) Mirtazapina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque tengan un HipoT4 subclínico, la conducta es tratar la depresión, que es el cuadro clínico. Sin embargo en la realidad también se debe tratar el HipoT4 subclínico, con la levoT4. Entre ambas respuestas, creo que la que hay que elegir es el antidepresivo ISRS, ya que en realidad el diagnóstico principal es la depresión. Además los síntomas no se explican para nada por el hipoT4, por tener apenas 5,4 de TSH. La verdad es que tampoco estamos 100% de que sea subclínico, porque no sabemos la T4. Es una pregunta mala.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 74 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Una paciente de 38 años inicia un cuadro de ánimo bajo, desconcentración e insomnio de conciliación, que inició después de que su marido fuera diagnos8cado de una enfermedad grave. No ha tenido cambios en el peso ni ideación suicida. Inicia psicoterapia sin notar mejoría de sus síntomas. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección para el manejo de esta paciente?

A) Bupropión
B) Venlafaxina
C) Sertralina
D) Carbonato de li2o
E) Mirtazapina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parecía inicialmente un trastorno adaptativo, pero pareciera evolucionar a una depresión, cuyo tratamiento de primera línea son los antidepresivos IRS, como la sertralina.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 88 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Paciente con diagnóstico de episodio depresivo mayor en tratamiento con escitalopram a dosis máxima por 2 meses sin respuesta. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cambiar a otro antidepresivo (venlafaxina o mirtazapina)
B) Agregar segundo antidepresivo (augmentación)
C) Derivar a psiquiatría para terapia electroconvulsiva
D) Continuar el mismo fármaco por 2 meses más
E) Agregar benzodiacepina a largo plazo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Falta de respuesta a ISRS a dosis máxima por 8 semanas = indicación de cambio de antidepresivo (switch) a otra clase: venlafaxina (IRSN), mirtazapina o bupropión, antes de considerar augmentación.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 134 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Una paciente de 32 años presenta un cuadro de 3 meses de angustia, asociada a afectación de su vida social y su trabajo, con dificultad para concentrarse. Ha bajado de peso y ya no realiza las actividades que le eran placenteras. Al preguntarle, de manera dirigida, reconoce intención suicida, sin un plan actual. La familia refiere que todo empezó hace 2 años, en relación a una ruptura sentimental de larga duración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo de tipo mixto
B) Distimia
C) Episodio depresivo mayor
D) Trastorno de angustia
E) Trastorno de angustia generalizada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Episodio depresivo mayor** (opción **C**). Es una depresión clásica (cumple criterios: si bien no tiene tristeza, sí tiene anhedonia).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 166 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Pregunta 166 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 30 años, embarazada con 32 semanas de gestación presenta un episodio depresivo mayor, sin síntomas psicóticos ni ideación suicida. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Terapia electroconvulsiva
B) Sertralina
C) Mirtazapina
D) Venlafaxina
E) Amitriptilina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En el embarazo, la depresión se trata con IRS, en especial con fluoxetina o sertralina. Si hubiese estado psicótica y con ideación suicida, de elección habría sido la TEC.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 32 5.01.1.007 · Primer episodio depresivo

Mujer con síntomas depresivos, hipersomnia, aumento de peso (relataba un cuadro clásico de depresión atípica):

A) Sertralina
B) Mirtazapina *No salían IMAO en las alternativas
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno de estrés postraumático

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Sertralina). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Mirtazapina *No salían IMAO en las alternativ, Trastorno de ansiedad generalizada) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 66 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente presenta múltiples episodios de 5 minutos de duración, recurrentes, en los que presenta mucha angustia, llanto, sensación de ahogo, parestesias en las cuatro extremidades y marcado miedo a sufrir un infarto al corazón. Ya no sale de la casa por miedo a presentar uno de esos episodios en la calle. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de pánico
B) Agorafobia
C) Trastorno de angustia generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Crisis de pánico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un trastorno de pánico o trastorno de ansiedad o de angustia clásico: crisis de pánico recurrentes e inexplicadas. Que ya no salga de su casa sugiere que, además, tiene agorafobia, pero predomina el diagnóstico de TP.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 12 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 28 años presenta un episodio de rápida instalación de marcada angustia y variados síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”, vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y miedo a morir. En las últimas 4 semanas ha presentado varios episodios similares, por lo que teme salir de su casa. Su examen físico es normal y los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

A) Amitriptilina 25 mg/día
B) Sertralina 50 mg/día
C) Risperidona 3 mg/día
D) Clonazepam 2 mg/día
E) Clorpromazina 300 mg/día

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene crisis de pánico recurrentes, por lo que es un trastorno de angustia o trastorno de pánico. El miedo a salir de su casa probablemente sea porque es "con agorafobia". El tratamiento de los trastornos ansiosos suele ser con antidepresivos IRS. Las benzodiacepinas sirven como tratamiento sintomático, pero el IRS es el tratamiento principal.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 132 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una mujer de 45 años, hace 6 semanas mientras compraba, presenta un episodio de opresión en el pecho, disnea, vértigo, temor a morir, palpitaciones, disfagia, sensación de lipotimia, visión borrosa y disestesias de las extremidades superiores, asociado a marcada angustia. Desde entonces ha presentado un episodio de similares características cada semana. No tiene otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el largo plazo?

A) Inhibidores de la monoaminoxidasa
B) Benzodiacepinas
C) Antipsicóticos atípicos
D) Antidepresivos tricíclicos
E) Inhibidores de la recaptura de serotonina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tuvo una crisis de pánico y, por recurrir, ahora tiene un trastorno de pánico (o de angustia o de ansiedad), que se trata con IRS (se pueden agregar BDZ, ejemplo alprazolam c/8 horas al inicio y luego SOS, pero solo como tratamiento sintomático). No confundir con trastorno de ansiedad generalizada, aunque el tratamiento es el mismo.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 103 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente presenta sensación de opresión precordial intensa, asociada a disnea, vértigo y dificultad para ver, que sucede de manera episódica, con varias recurrencias en el último tiempo. Está muy preocupada y además tiene mucho miedo a morir de un infarto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad social
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Agorafobia
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno conversivo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno de pánico** (opción **D**). Por las crisis de pánico reiteradas, es un trastorno de pánico clásico.. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 128 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 23 años, sin antecedentes, consulta muy preocupada porque desde hace un mes ha presentado en cuatro oportunidades cuadros de inicio agudo caracterizados por dolor torácico intenso, asociados a cefalea, mareos, parestesias y disnea, los cuales tienen una duración aproximada de una hora y ceden espontáneamente. Al preguntarle de forma dirigida, desconoce que puede desencadenar estas crisis. Trae electrocardiograma que le habrían tomado en el servicio de urgencias cuando consultó por una crisis el cual se aprecia normal. Los fármacos de elección para el tratamiento de esta paciente son:

A) Fluoxetina y carbamazepina
B) Amitriptilina y clonazepam
C) Citalopram y risperidona
D) Sertralina y diazepam
E) Paroxetina y lamotrigina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hay que darle un ISRS y al inicio una BDZ. La única opción que cumple con eso es la D. Los anticnovulsivantes y antipsicóticos no están indicados en el T. de angustia. Lo ideal sería empezar con fluoxetina 10 mg al día más alprazolam (no diazepam) 0,5 mg cada 8-12 horas y terminar con fluoxetina 20 mg al día, sin BDZ en un par de semanas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 37 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 28 años presenta episodios súbitos de marcada angustia, con miedo a morir y síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”, vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y sensaciones eléctricas en el cuerpo, en los que siente la necesidad de salir corriendo para su caasa. Ha presentado 5 episodios en las últimas 4 semanas y está muy preocupada por lo que le está pasando. Los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

A) Amitriptilina 150 mg
B) Sertralina 50 mg
C) Risperidona 3 mg
D) Clonazepam 6 mg
E) Clorpromazina 300

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Sertralina 50 mg** (opción **B**). Tiene un trastorno de pánico clásico, que se trata con antidepresivos IRS, como la sertralina.. El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 133 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Paciente con trastorno de pánico. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Sertralina 50 mg/día
B) Alprazolam 0,5 mg cada 8 horas
C) Litio 300 mg cada 12 horas
D) Haloperidol 5 mg/día
E) Valproato 500 mg/día

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Sertralina 50 mg/día** (opción **A**). Sertralina 50 mg/día. El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 67 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta en urgencias por cuadro de inicio brusco caracterizado por sensación de falta de aire, dolor en hemitórax izquierdo, mareos, sudoración y adormecimiento de manos, de 30 minutos de duración. Al examen físico presenta frecuencia cardiaca 120 por minuto, presión arterial 140/90, cardiopulmonar normal. Se solicita electrocardiograma que muestra ritmo sinusal, QRS angosto, sin signos de isquemia. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

A) Haloperidol
B) Diazepam
C) Lorazepam
D) Fenitoina
E) Clonazepam

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El lorazepam sublingual es el tratamiento de elección para las crisis de pánico. Su vida media es más corta que el diazepam y el clonazepam. Se debe dar por vía sublingual, de elección.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 113 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 36 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace tres meses ha presentado varios episodios caracterizados por taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, náuseas y sensación de muerte que tienen una duración de 30 minutos máximo y que ceden espontáneamente, por lo cual está muy preocupada, ya que dos de ellos le ocurrieron cuando se encontraba en una cafetería. Refiere que hace tres meses su pareja le pidió el divorcio en un restaurant, tras lo cual, intenta no salir de su hogar por miedo a que algo le ocurra y nadie la ayude. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno por ansiedad social
B) Trastorno adaptativo
C) Trastorno por estrés post traumático
D) Agorafobia
E) Trastorno de ansiedad

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un trastorno de ansiedad con agorafobia. Se debe preferir el diagnóstico de trastorno de ansiedad, por ser más completo, que el de agorafobia, que en este caso es un síntoma. De hecho el DSM IV clasifica el trastorno de pánico (o ansiedad o angustia) en con agorafobia y sin agorafobia

---

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 83 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 24 años presenta un cuadro de opresión precordial, disnea, parestesias en extremidades siperiores, palpitaciones y mucha ansiedad y miedo. Los síntomas se instalan en pocos minutos. ¿Cuál es el mejor medicamento para el manejo de esta crisis?

A) Diazepam
B) Fluoxetina
C) Lorazepam
D) Haloperidol
E) Clorpromazina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La crisis de pánico se trata con benzodiacepinas de acción rápida y corta (elección: lorazepam sublingual). Los antidepresivos IRS sirven para el trastorno de pánico (prevenir las crisis), no para la crisis de pánico mismo.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 134 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Paciente que refiere episodios de 'músculos que no responden', palpitaciones y sensación de muerte inminente. Hombre trabajador angustiado. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Arritmia cardíaca paroxística
C) Epilepsia parcial compleja
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno de somatización

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno de pánico** (opción **D**). Trastorno de pánico. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 103 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 31 años, embarazada de 3 meses, presenta angustia y temor, que aparece al estar en presencia de aglomeraciones de personas, especialmente en la calle, sintiéndose atrapada y ahogada en esas situaciones. Refiere síntomas similares al ir al supermercado y al tener que cruzar puentes muy largos, por lo que evita exponerse a esto y ha salido menos de su casa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Diazepam
B) Citalopram
C) Clorpromazina
D) Risperidona
E) Mirtazapina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El diagnóstico es una agorafobia. Se trata con antidepresivos IRS, al igual que todos los trastornos ansiosos crónicos de importancia. En el embarazo se pueden usar la sertralina, la fluoxetina y el citalopram. Las benzodiacepinas se intentan evitar en el embarazo, pero si tuviese síntomas demasiado intensos, se podría dejar una dosis bajas de alprazolam.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 155 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 50 años se siente atrapada en lugares como estacionamientos, au- topistas, los lugares al aire libre y los lugares cerrados, como ascensores. Por esto, ha dejado de salir de su casa. Además tiene cuadros de angustia episódica, con marcado miedo a perder el control. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Agorafobia
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de angustia
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Fobia específica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
A, C? También me parece una agorafobia por el miedo en relación a los lugares descritos (yo marqué A). Sin embargo, también puede ser un trastorno de angustia con

---

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 157 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 21 años presenta un episodio de rápida instalación, en 5 minutos, de marcada angustia, llanto, disnea y sensación de opresión precordial, más vértigo, imposibilidad de tragar, temblor y mucho miedo a morir. ¿Cuál es el tratamiento de esta crisis?

A) Risperidona
B) Carbamazepina
C) Clorpromazina
D) Fluoxetina
E) Lorazepam

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una crisis de pánico, es decir solo un síntoma. Se pregunta el tratamiento de la crisis, que es con benzodiacepinas de rápida acción (lorazepam, clonazepam e incluso alprazolam, aunque el lorazepam es el más usado), generalmente por una vía de rápida absorción (sublingual, EV o IM). No se debe confundir la crisis de pánico con el trastorno de pánico, que tiene múltiples crisis de pánico, sin una causa evidente, asociado a miedo a las crisis, evitación y angustia. El trastorno de angustia, en cambio, se trata con antidepresivos IRS, como fármaco más importante.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 133 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente presenta mucha angustia ante ciertas situaciones como lugares con muchedumbre, los malls, los ascensores con mucha gente, los espacios desolados y otros, ya que presenta miedo a sufrir un colapso y que nadie la ayude. Como antecedente, cuando niña lloraba por largas horas cuando iba al colegio y su mamá la dejaba. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de personalidad evitativo
B) Trastorno de ansiedad de separación del adulto
C) Trastorno de ansiedad social
D) Agorafobia
E) Trastorno de angustia generalizada

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Agorafobia** (opción **D**). Es una agorafobia clásica.. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 100 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una niña de 13 años ha presentado diez episodios de angustia muy intensa, asociadas a sensación de muerte, disnea, vértigo, ganas de ir corriendo a su casa, temor a estar volviéndose loca y llanto descontrolado, todo lo que ha afectado seriamente su calidad de vida. Además. Sus padres han debido ir a buscarla en 3 oportunidades al colegio en las últimas dos semanas, debido a estos síntomas. No presenta síntomas depresivos, aunque su autoestima se ha visto mermada por la situación. Su examen físico es normal ¿Cuál es el tratamiento más importante para esta paciente?

A) Sertralina
B) Quetiapina
C) Ácido valproico
D) Alprazolam
E) Diazepam

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Alprazolam** (opción **D**). El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 152 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 22 años presenta ansiedad persistente, relacionada a abandonar la cosa sola, por miedo a que le pase algo, sin recibir ayuda de sus familiares, lo que se ha agravado en el último tiempo. Por esto abandonó sus estudios hace un mes y en ge- neral ha visto seriamente afectada su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fobia social
B) Trastorno de angustia generalizada
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Trastorno de angustia
E) Agorafobia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Agorafobia** (opción **E**). Es una agorafobia clásica: miedo a no recibir ayuda.. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 31 5.01.1.001 · Trastorno de pánico con o

Una paciente de 42 años es traída por sus hijos, dado que ha dejado de salir de la casa o solo lo hace acompañada, por tiempo breve y con deseos de regresar pronto. Evita algunos lugares como los estacionamientos subterráneos y los ascensores, ya que le producen una sensación desagradable. Recientemente presentó mucha angustia al pasar por un túnel, en el que gritaba descontroladamente. Teme estar volviéndose loca y se muestra preocupada por su situación. Como antecedente, el cuadro comenzó luego de sospechar una infidelidad del marido. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno delirante
B) Agorafobia
C) Episodio psicótico
D) Trastorno de angustia generalizada
E) Trastorno de pánico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una agorafobia clásica. Como solo tuvo una crisis de pánico y relacionada con un estímulo agorafóbico clásico (puentes, estacionamientos, muchedumbres, lugares cerrados, lugares abiertos, metro) no es un trastorno de pánico (crisis de pánico recurrentes, sin causa aparente, el que puede venir con agorafobia).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 86 5.01.1.006 · Trastorno por estrés postr

Un paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta porque hace ocho meses mientras esperaba transporte colectivo, presenció un accidente automovilístico con resultados fatales, desde entonces intenta no acercarse mucho a la calle y cada vez que está en un paradero se encuentra muy inquieto, además refiere que le cuesta conciliar el sueño ya que presenta pesadillas frecuentemente. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno por estrés post traumático
B) Trastorno de ansiedad
C) Trastorno evitativo
D) Trastorno por estrés agudo
E) Trastorno adaptativo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno por estrés post traumático** (opción **A**). De libro y lleva más de 4 semanas.. El manejo de los contactos de pacientes con coqueluche se basa en la administración de azitromicina por cinco días, con la misma dosis que se utiliza en el tratamiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 61 5.01.1.006 · Trastorno por estrés postr

Un paciente de 50 años, presentó una pelea con su vecino hace 4 meses y desde hace un mes comienza con recuerdos del incidente, asociado a pesadillas recurrentes. En las últimas semanas evita pasar por fuera de la casa de su vecino por miedo, y su familia refiere que se encuentra con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Depresión reactiva
D) Depresión psicótica
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno de estrés postraumático** (opción **B**). Es un TEPT clásico.. El manejo de los contactos de pacientes con coqueluche se basa en la administración de azitromicina por cinco días, con la misma dosis que se utiliza en el tratamiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 67 5.01.1.006 · Trastorno por estrés postr

Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático

A) benzodiazepinas
B) ISRS
C) Triciclicos
D) Antipsicoticos tipicos
E) Antipsicóticos atípicos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La opción correcta es la **A** (benzodiazepinas). En este escenario clínico, benzodiazepinas se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 10 5.01.1.006 · Trastorno por estrés postr

Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 15 años, del que aún mantiene recuerdos y pesadillas, refiere episodios de algunos días de duración ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad. En ocasiones, presenta episodios de hasta dos días de duración de descontrol y rabia, en los que rompe ropa y electrodomésticos de su marido. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso ha presentado momentos en que actúa como una niña, con lenguaje y entonación de una menor de edad. Estos episodios cursan con amnesia de lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno de estrés postraumático

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno de estrés postraumático** (opción **E**). El manejo de los contactos de pacientes con coqueluche se basa en la administración de azitromicina por cinco días, con la misma dosis que se utiliza en el tratamiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 35 5.01.1.006 · Trastorno por estrés postr

Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 14 años, refiere episodios de ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad, que luego de algunos días mejoran. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso actúa como niña y luego no lo recuerda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno esquizotípico
E) Trastorno de estrés postraumático

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un trastorno de estrés postraumático, con síntomas disociativos. Era una pregunta difícil, pero cumple con los criterios del CIE-10.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 28 5.01.1.006 · Trastorno por estrés postr

Un paciente de años, desde hace 10 días comienza con angustia y malestar general, asociado a dificultades para dormir y pesadillas. Se ha sentido agobiado y triste. Refiere que ace dos semanas fue testigo de un asalto, en el cual la víctima fue herida con un arma de fuego. Además, ha evitado salir de su casa y el contacto con otras personas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno agudo por estrés
B) Episodio depresivo mayor
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Trastorno de angustia generalizada
E) Trastorno de angustia social

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno de estrés postraumático** (opción **C**). El manejo de los contactos de pacientes con coqueluche se basa en la administración de azitromicina por cinco días, con la misma dosis que se utiliza en el tratamiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 132 5.01.1.016 · Trastornos de la personali

Una paciente de 32 años, madre de 4 hijos, de distintos padres, de los cuales no se hace cargo, tiene relaciones inestables y problemas frecuentes con sus compañeros de trabajo. Pelea frecuentemente con su familia y como antecedente, ha tenido varios episodios de autoagresión e intentos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno límite de la personalidad
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno delirante
E) Trastorno depresivo mayor

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno límite de la personalidad** (opción **B**). Es un TP limítrofe clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 79 5.01.1.016 · Trastornos de la personali

Una paciente tiene relaciones interpersonales intensas e inestables y problemas frecuentes con las demás personas. Presenta antecedentes de dos intoxicaciones medicamentosas y autoagresiónes. Además estuvo en tratamiento por bulimia hace un año. Tiene un sentimiento crónico de inutilidad y vacío. Además es impulsiva en el consumo de alcohol y compras. ¿A qué trastorno de la personalidad corresponde el cuadro?

A) Histriónico
B) Limítrofe
C) Narcisista
D) Antisocial
E) Dependiente

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Limítrofe** (opción **B**). Cuadro clásico. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 98 5.01.1.016 · Trastornos de la personali

Un paciente de 30 años, consulta debido a que se siente deprimido. Es padre de tres hijos con tres mujeres diferentes, tiene antecedentes de múltiples fracasos académicos y laborales y se encuentra sin actividad laboral en la actualidad. Al interrogatorio, consume alcohol con cierta frecuencia, bebiendo 3 o 4 días a la semana en cantidad que él considera moderada, aunque reconoce que se emborracha los fines de semana. Además, con frecuencia se involucra en actividades riesgosas y presenta una autoimagen negativa. En el pasado, ha tenido ideación suicida con autoagresión, aunque no la tiene en la actualidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno de conducta
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno adaptativo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno de Personalidad Límite: El caso presentado describe un trastorno de personalidad límite clásico. Se recomienda revisar el resumen de psiquiatría.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 112 5.01.1.016 · Trastornos de la personali

Una paciente de 28 años tiene problemas frecuentes con sus familiares, con quienes suele pelearse y distanciarse, pero luego de algunos meses retoma la relación, como si nada hubiese pasado. Además tiene antecedente de haber ingerido medicamentos con intención suicida y haberse autoagredido. Además ha cambiado varias veces de trabajo, ya que le cuesta atenerse a las normas, lo que le ha generado problemas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Trastorno bipolar
D) Distimia
E) Depresión mayor

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno de personalidad limítrofe** (opción **B**). Es un clásico trastorno limítrofe de la personalidad.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 84 5.01.1.016 · Trastornos de la personali

Una paciente que desde niña es muy tímida, tiene dificultades para relacionarse con otras peronsonas, por temor al rechazo. No ha tenido pareja y evita las situaciones en que hay muchas personas. Le gustaría mejorar su situación y desarrollar su autoestima. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad evitativo
B) Trastorno de personalidad dependiente
C) Fobia social
D) Agorafobia
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno de personalidad evitativo** (opción **A**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 58 5.01.1.016 · Trastornos de la personali

Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno evitativo de la personalidad
B) Síndrome de Asperger
C) Depresión mayor
D) Distimia
E) Fobia social

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un trastorno evitativo clásico (inicio temprano, pocos amigos, etc.), aunque puede confundirse con una fobia social, sin embargo, en la fobia social sí tienen amigos, solo que no hacen cosas frente a ellos, en las que los puedan juzgar.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 122 5.01.1.016 · Trastornos de la personali

Una paciente de 28 años tiene relaciones amorosas muy intensas, se viste muy provocativa y es muy coqueta, lo que le ha traído problemas con sus pares a las que ella las llama “envidiosas”. Durante la entrevista es muy exagerada al contar sus problemas. El trastorno de la personalidad más probable en este caso es:

A) Narcisista
B) Limítrofe
C) Histriónico
D) Dependiente
E) Antisocial

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene mezcla de narcisismo (envidia), limítrofe (intensas), pero más de histriónica (provocativa al vestir, coqueta, exagerada).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 155 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Una paciente de 55 años, se lava las manos recurrentemente porque siente que se encuentran sucias, el hecho de no hacerlo rápidamente le provoca gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de ansiedad
B) Ansiedad específica
C) Trastorno dismórfico corporal
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La opción correcta es la **E** (Trastorno obsesivo compulsivo). En este escenario clínico, trastorno obsesivo compulsivo se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 11 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Una paciente de 32 años presenta imágenes recurrentes, en que se ve a sí misma cortando a su hijo de 12 meses, con un cuchillo. Aquello le genera mucha angustia y miedo de dañar a su hijo. Por ello, nunca se queda a solas con el niño y sacó todos los cuchillos de los cajones de la casa. Está muy angustiada y triste, porque no quiere que le pase nada malo a su hijo y teme tener problemas con sus familiares o perder la tuición del niño, por lo que no le ha contado su problema a nadie. Ha pensado incluso en morir, con tal de proteger a su familia. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno bipolar
B) Episodio psicótico
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno depresivo mayor
E) Trastorno de adaptación

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno obsesivo compulsivo** (opción **C**). Es un TOC clásico, con obsesión de causar daño y compulsión evitativa.. La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 87 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Hombre de 32 años que tuvo leucemia linfoblástica en la infancia. Curado. Ahora consulta por lavado de manos compulsivo más de 30 veces al día, incapacitante, relacionado con miedo a contaminarse. Reconoce que es excesivo pero no puede parar. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
B) Fobia específica a gérmenes
C) Hipocondría
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) TEPT por su historia oncológica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Compulsiones (lavado de manos) repetitivas + egodistónicas (reconoce que es excesivo) + incapacitantes = TOC. La compulsión de limpieza es la más frecuente en TOC.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 127 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Un paciente de 32 años consulta por la idea recurrente de que debe limpiar sus utensilios de alimentación para evitar adquirir una infección intestinal. Refiere que se cepilla los dientes durante 15 minutos y luego se enjuaga la boca por 10 minutos más. Reconoce que a veces quiere dejar de hacerlo, pero no puede evitarlo. Como antecedente, sufrió de leucemia aguda a los 7 años, siendo manejado con quimioterapia y logrando la curación de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Manía aguda
B) Trastorno por descontrol de impulsos
C) Trastorno de personalidad
D) Esquizofrenia
E) Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno Obsesivo-Compulsivo: El cuadro clínico describe un trastorno obsesivo-compulsivo clásico, con obsesión por la contaminación y compulsión por la limpieza.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 15 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Un hombre de 34 años, que fue padre hace 2 meses, presenta imágenes recurrentes y desagradables, en las que él se ve asfixiando a su bebé con una almohada. Se siente muy angustiado y evita el contacto con su hijo, por miedo a hacerle daño. No ha querido contarle a su cónyuge, ya que se siente avergonzado y cree que se puede estar volviendo loco. El diagnóstico más probable es:

A) Depresión psicótica
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Trastorno adaptativo
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno delirante

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un TOC clásico de con obsesión de acción negativa y compulsión de evitación. Otros ejemplos preguntados han sido la obsesión de ser pedófilo, ser infiel, agredir a las personas de la calle, empujarlas al metro.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 13 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Un paciente de 32 años se lava las manos repetidamente durante el día. Al examen está lúcido, cooperador, pero angustiado. Refiere que una voz interior le ordena lavarse las manos y no puede desobedecerle. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A) Litio
B) Fluoxetina
C) Olanzapina
D) Carbamazepina
E) Alprazolam

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un TOC, que, al igual que todos los trastornos ansiosos crónicos (TA, TAG, TEPT), se trata con antidepresivos (lo más importante), si bien también se dejan benzodiacepinas en dosis bajas. La "voz interior" no es una alucinación, mientras no la escuche directamente o la considere algo ajeno o externo a él.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 73 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Un paciente de 36 años presenta la idea de que puede ser pedófilo. Aquello lo angustia mucho y le aterra la idea de acercarse a los niños. Por ello reza y evita situaciones en las que estará en contacto con niños. Su diagnóstico es:

A) Trastorno delirante
B) Parafilia
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno de la inclinación sexual
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un TOC clásico con obsesión de conducta inmoral y compulsión de evitación y rezar. Se ha preguntado antes con la idea de ser homosexual (que en el caso puntual le generaba mucha angustia al paciente y era una idea recurrente, por lo que sí era una obsesión).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 34 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Una paciente de 32 años presenta imágenes recurrentes, en que se ve a sí misma matando a su hijo de 12 meses, con un cuchillo. Por ello, sacó todos los cuchillos de la casa y nunca se queda a solas con él. Está muy angustiado y triste, porque no quiere que le pase nada malo a su hijo y teme perder la tuición del niño. Ha pensado incluso en morir, con tal de proteger a su familia. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno delirante
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno depresivo mayor
E) Trastorno de estrés postraumático

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un TOC clásico (obsesión de dañar y compulsión de no exponerse a la posibilidad). Igual era difícil, porque probablemente se había complicado con una depresión.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 68 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Un paciente consulta muy angustiado, porque cree ser pedófilo. Le aterra acercarse a los niños y no sabe qué hacer, a pesar de que sabe que su idea es rara. Refiere que reza para no serlo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno delirante cónico
B) Trastorno esquizoafectivo
C) Trastorno psicótico agudo
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Parafilia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno obsesivo compulsivo** (opción **D**). Tiene la obsesión (idea que produce angustia) y la compulsión (reza y evita los niños). La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 37 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Hombre piensa que puede ser pedofilo, le perturba el pensamiento recurrente asi q cuando lo piensa repite una frase: (repetida años anteriores) a. TOC

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno bipolar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Trastorno de ansiedad generalizada). La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 64 5.01.1.002 · Trastorno obsesivo compuls

Un niño de 7 años comienza hace 3 meses con pestañeo frecuente asociado a expre- siones faciales como levantar las cejas, a lo que en el último tiempo se agregan movi- mientos involuntarios de las extremidades superiores, asociados a sacudidas bruscas de la cabeza y en los últimos días además se ha agregado carraspera. ¿Cuál es el diag- nóstico más probable?

A) Síndrome de Gilles de la Tourette
B) Trastorno obsesivo
C) Corea
D) Enfermedad por tics
E) Crisis epiléptica parcial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene múltiples tics. El síndrome de Tourette requiere al menos 1 año de duración, más afectación del lenguaje.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 161 5.01.4.001 · Estudio de hormonas tiroid

Un paciente de 30 años, sin antecedentes, consulta por fatigabilidad asociada a disminución de peso desde hace tres meses. Al entrevistarlo de forma dirigida refiere que hace tres meses tuvo una ruptura sentimental, por lo que desde entonces además de los síntomas mencionados ha estado con pena, insomnio y desconcentración. Su examen físico resulta normal y su índice de masa corporal es 22. El examen de elección para descartar causa orgánica en este caso es:

A) Tirotropina
B) VDRL
C) Hemograma
D) Creatinina y enzimas hepáticas
E) Glicemia de ayuno

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una depresión. Hay que pedir TSH = tirotropina = hormona tiroestimulante (el más importante), pero también hemograma y glicemia.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 155 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Una paciente de 39 años es despedida de su trabajo y, a las pocas horas, presenta imposibilidad de realizar movimientos con ambas manos. Al examen físico tiene tono muscular y reflejos normales. Además, llama la atención la falta de concordancia entre el relato de los síntomas y la actitud de la paciente, que se ve muy tranquila con lo que sucede. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno dismórfico corporal
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno facticio
D) Trastorno somatomorfo
E) Trastorno disociativo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un trastorno conversivo típico: síntomas neurológicos de inicio rápido y sin una causa orgánica que los explique. En estricto rigor sí es un trastorno somatomorfo (D), ya que los trastornos conversivos son un tipo de trastornos somatomorfos, pero la B es más específica.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 57 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Una paciente femenina de 33 años, que hace 5 años comienza con síntomas recurrentes y variables de molestias genitourinarias, y gastrointestinales, asociados a mareos y prurito, ha consultado en reiteradas ocasiones a especialistas los cuales han descartado enfermedad órganica, llegando incluso a realizarse una laparoscopía exploradora, que no tenía alteraciones. Sus síntomas le impiden trabajar. ¿Cuál es el diagnostico más probable?

A) Hipocondria
B) Trastorno facticio
C) Trastorno de personalidad
D) Trastorno de somatización
E) Simulación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un trastorno de somatización clásica (muchos síntomas distintos, sin causa orgánica). El haber accedido a la laparoscopía, descarta la simulación y el T. facticio.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 88 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Un paciente de 50 años presenta cefalea, náuseas, mareos y epigastralgia, de dos años de evolución. Cuenta con múltiples exámenes que descartan causa orgánica, sin embargo, él insiste en exigir más estudios. No se identifica ánimo de obtener alguna ganancia. El diagnóstico más probable es un trastorno:

A) Depresivo mayo
B) Delirante
C) Obsesivo compulsivo
D) De somatización
E) Facticio

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **De somatización** (opción **D**). Tiene un T. de somatización clásico. Por no tener ánimo ganancial, no es facticio.. Los trastornos somatomorfos se caracterizan por síntomas físicos (somáticos) sin causa orgánica que los explique completamente, de causa psíquica (generalmente estrés). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 142 · 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Una paciente de 41 años que trabaja como ejecutiva en una empresa, consulta por cefalea, náuseas y mareos frecuentes y recurrentes. Su examen físico es normal y refiere sentirse estresada y exigida en su trabajo, ya que los resultados de la empresa dependen de su desempeño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno disociativo
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno facticio
E) Trastorno adaptativo de tipo ansioso

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno Somatomorfo: Este audio describe un trastorno somatomorfo, caracterizado por síntomas físicos sin una causa orgánica subyacente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 70 · 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Un paciente sufre una fractura de muñeca, en relación a un accidente laboral. Presenta con mucho dolor, a pesar de haber evolucionado bien y de llevar mucho tiempo desde el accidente. Tiene antecedente de cuadros previos similares, con dolores crónicos y difíciles de tratar. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno conversico
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Depresión reactiva
E) Trastorno facticio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un trastorno somatomorfo por dolor (no por somatización, ni hipocondriaco). No hay información para pensar que sea facticio (intencional para ganar cuidados y afecto) ni simulación (intencional, para ganar dinero o pensiones).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 115 · 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal, asociado a náuseas y malestar general. Además ha tenido disestesias en la piernas y sensación de frío, más otras molestias inespecíficas. Refiere estar angustiada por lo que le sucede y relata que está pasando por un periodo de estrés. Se solicitan exámenes que descartan patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno hipocondriaco
D) Trastorno facticio
E) Depresión

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Depresión** (opción **E**). Es un trastorno de somatización clásico.. Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 14 · 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Una paciente presenta disminución de la sensibilidad e imposibilidad de mover la extremidad superior derecha, luego de haber sido despedida de su trabajo. Su examen neurológico no tiene alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno disociativo
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno por simulación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un trastorno conversivo clásico. Sin embargo, son un tipo de trastorno somato- morfo. No debería haber un distractor correcto.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 9 · 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Un paciente de 65 años presenta un cuadro de 7 días de dificultades para mover pierna derecha. En su examen físico se aprecia que al caminar arrastra ostentosamente la pierna derecha y se constata tono muscular y reflejos normales, por lo que se descarta patología orgánica. Refiere que los síntomas comenzaron luego de presenciar un accidente de tránsito, en el que hubo múltiples heridos de gravedad. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno disociativo
C) Trastorno de somatización
D) Trastorno facticio
E) Episodio psicótico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno conversivo** (opción **A**). Es un trastorno conversivo clásico.. Los trastornos somatomorfos se caracterizan por síntomas físicos (somáticos) sin causa orgánica que los explique completamente, de causa psíquica (generalmente estrés). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 73 · 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Un paciente de 45 años presenta un cuadro de 2 semanas de dificultades para mover las extremidades derechas. Los síntomas comenzaron en relación a un accidente de tránsito que él presenció. En su examen se aprecia que al caminar arrastra aparatosamente la pierna derecha y se constata tono muscular y reflejos normales, por lo que se descarta patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno disociativo
C) Trastorno de somatización
D) Trastorno facticio
E) Trastorno dismórfico corporal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno conversivo** (opción **A**). Es un trastorno conversivo clásico: síntomas neurológicos sin una causa orgánica de base.. Los trastornos somatomorfos se caracterizan por síntomas físicos (somáticos) sin causa orgánica que los explique completamente, de causa psíquica (generalmente estrés). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 82 5.01.1.020 · Trastornos somatomorfos

Paciente que decía que le “temblaba el cuerpo” y en ocasiones se quedaba paralizada porque se subia al auto “no quería ir al trabajo y músculos no le respondian” y que fue estudiada por varios médicos (neurólogos e internistas) sin hallazgos y ya está cansada y quiere que la dejen morir, su familia o amigos estan preocupados porque siempre ha sido una trabajadora ejemplar:

A) Conversivo
B) Hipocondria
C) Depresión.
D) Facticio
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Conversivo). Los trastornos somatomorfos se caracterizan por síntomas físicos (somáticos) sin causa orgánica que los explique completamente, de causa psíquica (generalmente estrés). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 146 5.01.1.008 · Trastorno depresivo (recur

Un hombre de 45 años consulta por ánimo deprimido, anhedonia, alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse, los cuales han afectado su desempeño laboral y social durante los últimos 4 meses. No refiere antecedentes de episodios maníacos ni psicosis, pero sí un episodio depresivo mayor hace cinco años, tratado con éxito con fluoxetina. En esta ocasión, se inició tratamiento con escitalopram (20 mg/día) durante 4 semanas, pero no ha mostrado mejoría significativa en sus síntomas. No refiere efectos secundarios importantes con el medicamento y su función tiroidea y niveles de vitamina B12 y ácido fólico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de escitalopram
B) Cambiar el tratamiento a venlafaxina
C) Iniciar terapia electroconvulsiva (TEC)
D) Agregar un antipsicótico atípico como quetiapina
E) Cambiar el tratamiento a fluoxetina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tratamiento de la Depresión: El tratamiento de elección para un episodio depresivo mayor unipolar son los antidepresivos ISRS, especialmente si el paciente ya ha respondido a este tipo de medicamento. Si no hay respuesta después de 4 semanas, se recomienda cambiar a un antidepresivo dual como venlafaxina o duloxetina.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 71 5.01.1.008 · Trastorno depresivo (recur

Una paciente de 82 años, con antecedente de 2 intentos de suicidio previos, presenta un cuadro de ánimo bajo, irritabilidad, problemas de memoria. Su minimental es 27/30, su GDS (escala de depresión geriátrica) es de 12/15 y presenta ideas delirantes de daño. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Terapia electroconvulsiva
B) Iniciar sertralina
C) Hospitalizar con mirtazapina
D) Indicar clorpromazina
E) Hospitalizar con amitriptilina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una depresión psicótica en el adulto mayor y no está clara la ideación suicida actual. Solo quien hizo la pregunta sabe cuál es la respuesta correcta. No es ni la amitriptilina, ni la clorpromazina, porque están contraindicadas en el adulto mayor. Está suficientemente mal, como para pensar en hacerle terapia electroconvulsiva.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 166 5.01.1.008 · Trastorno depresivo (recur

Un paciente de 60 años, con antecedente de depresión, en tratamiento con paroxe- tina 40 mg en la noche y clonazepam 0,5 mg en la noche, hace 7 días disminuyó la dosis de los fármacos a la mitad. Hace 4 días inicia un cuadro de malestar general, asociado a inquietud, insomnio, sensación de pinchazos eléctricos en los brazos y miedo a morir. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acatisia
B) Síndrome de discontinuación de antidepresivos inhibidores de la recaptura de sero- tonina
C) Síndrome de privación de benzodiacepinas
D) Manía aguda
E) Delirium

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome de discontinuación de antidepresivos inhibidores de la recaptura de sero- tonina** (opción **B**). Es un síndrome de discontinuación de ISRS clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 30 5.01.2.002 · Agitación psicomotora

Un paciente de 39 años es detenido, porque estaba haciendo disturbios en la vía pública. Es llevado para constatar lesiones y, al examen no coopera y se muestra angustiado y agitado, con agresión verbal hacia el personal de salud, sin llegar a la agresión física. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar haloperidol 5 mg intramuscular
B) Risperidona 1 mg vía oral
C) Diazepam 5 mg intramucular
D) Contención verbal
E) Contención física

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Contención física** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Administrar haloperidol 5 mg intramuscular, Risperidona 1 mg vía oral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 130 5.01.2.002 · Agitación psicomotora

Paciente ingresado con agitación, agresión verbal y movimientos inquietos de manos y pies. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Haloperidol 5 mg IM inmediato
B) Contención verbal y ambiental
C) Lorazepam 2 mg IM
D) Contención física
E) Olanzapina 10 mg IM

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Contención verbal y ambiental** (opción **B**). Contención verbal y ambiental. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 72 · 5.01.2.002 · Agitación psicomotora

Un paciente de 24 años presenta un cuadro de ánimo exaltado e irritabilidad. Presenta verborrea y muchas ideas de éxito y negocios. Los familiares se muestran muy preocupados. Actualmente duerme dos horas al días, porque no se siente cansado. Al examen físico presenta verborrea, luego se vuelve agresivo y finalmente se agita. ¿Qué fármaco debe recibir en este momento?

A) Olanzapina
B) Escitalopram
C) Ácido valproico
D) Litio
E) Haloperidol

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Haloperidol** (opción **E**). Lo primero en la manía agitada es el Haldol. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 8 · 5.01.2.002 · Agitación psicomotora

Un paciente de 25 años, esquizofrénico, recibe 5 mg de haloperidol intramuscular, por un cuadro de agitación psicomotora. A las dos horas presenta contracción tónica y dolorosa del cuello, con desviación hacia la derecha. ¿Cuál es el tratamiento de este cuadro?

A) Bromocriptina
B) Clorpromazina
C) Lorazepam
D) Diclofenaco
E) Propanolol

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El manejo de la distonía aguda (tortícolis espasmódica, en este caso) es suspender el antipsicótico más administrar BDZ.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 105 · 5.01.5.002 · Examen físico y neurológic

Un paciente esquizofrénico, recién diagnósticado, inicia tratamiento con risperidona. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a temblor, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parkinsonismo por fármacos
B) Distonía aguda
C) Disquinesia aguda
D) Acatisia
E) Manía aguda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Acatisia** (opción **D**). Es una acatisia clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 141 · 5.01.5.002 · Examen físico y neurológic

Un hombre de 48 años, diagnosticado de esquizofrenia, presenta episodio agitación, por lo cual se aumenta la dosis de haloperidol de 10 a 20 mg al día, evolucionando con malestar general, dificultad para la marcha y disminución del nivel de conciencia. Al examen físico, tiene FC: 100x', PA: 140/90 mmHg, temperatura 38 grados Celsius y rigidez de las extremidades. Se solicitan exámenes, en los que destaca leucocitosis de 19.000 blancos por mm3 y CPK de 1200 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Distonía
B) Síndrome neuroléptico maligno
C) Síndrome anticolinérgico
D) Síndrome adrenérgico
E) Distrofia muscular de Duchenne

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome neuroléptico maligno clásico: se inicia o aumenta la dosis de un neuroléptico (sinónimo de antipsicótico) y evoluciona con la triada de rigidez, hipertermia y compromiso de conciencia.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 73 · 5.01.5.002 · Examen físico y neurológic

Un paciente bipolar recibe haloperidol y tras su tercera dosis presenta contracción persistente y dolorosa del cuello y del brazo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Distonía aguda
B) Acatisia
C) Síndrome neuroléptico maligno
D) Balismo
E) Disquinesia tardía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Distonía aguda** (opción **A**). Cuadro clásico. Es distonía por antipsicóticos. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 57 · 5.01.5.002 · Examen físico y neurológic

Un paciente esquizofrénico, recién diagnosticado, inicia tratamiento con risperidona 3 mg/día hace 5 días. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a angustia, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome neuroléptico maligno
B) Distonía aguda
C) Disquinesia aguda
D) Acatisia
E) Hipomanía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Acatisia** (opción **D**). Es una acatisia clásica. Ver resumen de psiquiatría.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 14 5.01.5.002 · Examen físico y neurológic

Un paciente de 18 años, adicto a la pasta base, presenta un episodio psicótico, en relación al consumo, el que es manejado con haloperidol 5 mg por vía intramuscular. Al día siguiente presenta contracción tónica del cuello, que desvía la cabeza hacia la izquierda, con intenso dolor. El diagnóstico más probable es:

A) Distonía aguda
B) Acatisia
C) Síndrome neuroléptico maligno
D) Disquinesia tardía
E) Parkinsonismo farmacológico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Distonía aguda** (opción **A**). Es una distonía aguda clásica, de tipo "tortícolis espasmódica".. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 145 5.01.1.018 · Trastornos de la conducta

Una paciente de 17 años es traída por su padre, quien se muestra muy preocupado porque la considera muy delgada y siente que come muy poco. Relata que solo come una fracción del plato que se sirve en su casa y que deja gran parte de la comida que se le envía al colegio. La paciente comenta que la mayoría de sus compañeras son igualmente delgadas y no considera que tenga un problema, más allá de mostrarse molesta por la insistencia de su padre en consultar. Su IMC es de 16 kg/m². ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Trastorno obsesivo de la personalidad
B) Bulimia nervosa
C) Anorexia nervosa
D) Dismorfofobia
E) Sana

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una anorexia nerviosa clásica (anorexia nervosa en latín) con restricción alimentaria, bajo peso (IMC 16 kg/m²), minimización del problema, normalización de la delgadez y escasa conciencia de problema. Las niñas y adolescentes son el grupo en el que suele comenzar.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 4 5.01.1.018 · Trastornos de la conducta

Mujer de 17 años, con IMC 15.5 kg/m², niega sentirse enferma, refiere que todas sus amigas hacen lo mismo, realiza ejercicio intenso a diario y come menos de un cuarto de su ración habitual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Anorexia nerviosa
B) Bulimia nerviosa
C) Trastorno por atracón
D) Depresión mayor con anhedonia
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Bajo peso severo + restricción alimentaria voluntaria + negación de la enfermedad + ejercicio compulsivo = anorexia nerviosa restrictiva.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 168 5.01.1.018 · Trastornos de la conducta

Una niña de 15 años presenta disconformidad con su cuerpo, por lo que lo oculta, utilizando ropa 2 o 3 tallas más grandes. Además, tiene retraimiento social y gran preocupación por las calorías que ingiere. Los padres refieren que anda con náuseas en el último tiempo, por lo que come poco y ha bajado de peso. Sin embargo ella se había negado a acudir al médico. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno distímico
B) Trastorno alimentario mixto
C) Anorexia nervosa
D) Trastorno depresivo mayor
E) Bulimia nervosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una forma clásica de presentación de la anorexia, aunque no muestren todos los criterios (bajo peso, preocupación por el peso, alteración de la percepción corporal y amenorrea). Es frecuente que la paciente lo oculte, mienta o manipule a la familia, para que no la obliguen a subir de peso.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 45 5.01.1.018 · Trastornos de la conducta

Paciente de 23 años, que desde hace 6 meses experimenta desánimo, que ella dice que es causado por estar muy disconforme con su figura. Refiere que experimenta momentos en que come muchas galletas, sin parar, hasta ser imposible seguir comiendo, en especial cuando está ansiosa. Además, tiene miedo de reprobar en la universidad. Refiere que 3 veces por semana, puede trotar 5 horas y comer menos de 200 Calorías al día. Niega provocarse vómitos, ya que refiere que no puede inducírselos, aunque ha intentado. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A) Anorexia nervosa
B) Trastorno por atracones
C) Depresión mayor
D) Bulimia nervosa
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una bulimia, con los atracones característicos y además con la purga, por medio de ejercicios y ayuna (no solo se purga con vómitos o laxantes).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 76 5.01.1.018 · Trastornos de la conducta

¿Cuál de los siguientes hallazgos del examen físico sugieren un trastorno de conducta alimentaria en una adolescente?

A) IMC de 20
B) Hipertrofia de las parótidas
C) Telangiectasias periorales
D) Pulso dicroto
E) Hiperpigmentación areolar

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Hipertrofia de las parótidas** (opción **B**). La hipertrofia de parótidas es un signo de vómitos recurrentes.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 80 5.01.1.018 · Trastornos de la conducta

Una paciente de 17 años ha bajado 15 kilogramos en el último tiempo. Su IMC actual es de 16. Tiene mucho miedo a engordar y de hecho quiere bajar un poco más de peso, por lo que luego de comer se induce vómitos, con mucha frecuencia. Está en amenorrea desde hace 4 meses. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno alimentario no especificado
B) Bulimia nervosa
C) Anorexia nervosa
D) Depresión mayor
E) Distimia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Anorexia nervosa** (opción **C**). La purga no es exclusiva de la bulimia. La anorexia puede tenerla.. 1. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 141 5.01.1.018 · Trastornos de la conducta

Femenina con atracones, luego salía a correr 5 hrs y consumía 200 kcal/día, intentaba vomitar pero no podía:

A) Bulimia nerviosa
B) Anorexia
C) Trastorno por atracones
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Bulimia nerviosa). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Anorexia, Trastorno por atracones) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 72 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Un paciente de 70 años, con antecedente de daño hepá8co crónico y consumo de alcohol ac8vo, consulta porque quiere dejar de beber. Consume 3 litros de cerveza al día y comenta que hace un año intentó bajar el consumo a 1 litro al día, sin embargo, presentó agitación, angus8a y la visualización de insectos que él no sabía que no eran reales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar el cese inmediato del consumo de alcohol
B) Iniciar disulfiram
C) Hospitalizar para desintoxicación
D) Indicar lorazepam
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene alcoholismo y está motivado para dejar de consumir, pero Gene antecedente de un síndrome de absGnencia grave, con delirium tremens previo, por lo que lo razonable es que inicie la disconGnuación bajo supervisión médica, en el hospital. Si presentara síntomas de absGnencia grave, se trataría con Lorazepam, ya que el diazepam no se recomienda en el daño hepático crónico.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 103 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Paciente de 55 años alcohólico crónico, 48 horas después de dejar de beber presenta agitación severa, alucinaciones visuales de insectos, temblor generalizado, taquicardia 120 lpm, sudoración y fiebre 38°C. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A) Delirium tremens: diazepam EV + tiamina + corrección hidrolectrolítica
B) Psicosis alcohólica: haloperidol
C) Meningoencefalitis: antibióticos EV
D) Hipoglicemia: glucosa EV en bolo
E) ACV isquémico: tPA

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Delirium tremens: síndrome de abstinencia alcohólica grave (48-72h post cese). Tratamiento: benzodiacepinas IV (diazepam o lorazepam) para prevenir convulsiones + tiamina IM + fluidos.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 131 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Paciente con hálito alcohólico en urgencias; TAC descarta lesiones. A las 48 horas, agitación y desorientación. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Haloperidol 5 mg IM
B) Tiamina 100 mg EV
C) Suero glucosado 10% endovenoso
D) Metadona oral
E) Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica)

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica)** (opción **E**). Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 36 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Paciente masculino con consumo OH crónico, pierde su trabajo, se fractura tobillo y se hospitaliza, pide alta voluntaria para ir a tomar cerveza, qué conducta define mejor la “adicción” x OH:

A) La conducta durante la hospitalización
B) Pérdida de trabajo
C) Embriaguez
D) La frecuencia del consumo
E) Laparotomía exploratoria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **La conducta durante la hospitalización** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 114 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Un paciente alcohólico es ingresado, indicándosele tratamiento con diazepam 0,5 mg/noche y haloperidol 0,5 mg/noche. Evoluciona con sudoración, inquietud, palpita- ciones e insomnio con angustia que es mayor en la noche,

A) Acatisia
B) Síndrome de privación de alcohol
C) Síndrome neuroléptico maligno
D) Distonía aguda
E) Diquinesia aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome de abstinencia moderado. No tiene delirium tremens, ni convul- siones (sería severo).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 133 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Un paciente de 20 años, fumador y consumidor de alcohol, desde hace un mes presenta consumo diario de alcohol. Decide suspenderlo hace algunos días, sin embargo, evoluciona con intranquilidad, sudoración, palpitaciones y angustia, asociado a insomnio y malestar general, que han ido empeorando. Sus padres refieren que está muy asustado y que ha fumado marihuana en los últimos dos días, para disminuir su ansiedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Delirium tremens
B) Síndrome de abstinencia de alcohol
C) Síndrome de abstinencia de marihuana
D) Esquizofrenia
E) Intoxicación por canabis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome de privación alcohólica clásico (suele ser peor en el día 3-4 desde el cese del consumo). El que consuma marihuana es algo que puede orientar a un brote, en contexto de esquizofrenia, pero la clínica es distinta y, además, en este caso aparecieron los síntomas antes y comenzó a fumar marihuana después.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 81 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Un paciente de 54 años, alcohólico hace 20 años, que en contexto de una festividad consume abundante alcohol, con cerca de 3 botellas de vino al día. Se reintegra a su trabajo y al tercer día después de suspender el consumo, evoluciona con un cuadro de malestar general, ansiedad, temblor, seguido luego de agitación psicomotora y alucinaciones. ¿Qué fármaco debe administrarse?

A) Diazepam
B) Fenobarbital
C) Fenitoína
D) Haloperidol
E) Tiamina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un delirium tremens (abstinencia de alcohol grave) se trata con diazepam. Si tiene daño hepático crónico, es con lorazepam

---

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 15 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Un paciente de 42 años, alcohólico, consume cerca de 3 botellas de vino al día, durante dos semanas. Luego de 3 días de abstinencia, presenta agitación psicomotora, desorientación y temblor, asociado a alucinaciones visuales. ¿Cuál es el tratamiento inicial para el manejo de este paciente?

A) Tiamina
B) Zink
C) Clorpromazina
D) Haloperidol
E) Diazepam

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un clásico delirium tremens, que se trata con benzodiacepinas, idealmente diazepam, que tiene vida media larga, a menos que tenga DHC, en que se debe tratar con lorazepam. Las demás causas de agitación psicomotora psiquiátrica se tratan con haloperidol, pero esta es una excepción que hay que saber.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 51 5.01.1.012 · Dependencia de alcohol

Un paciente con antecedente de daño hepático crónico por consumo de alcohol, be- bedor activo, que toma 1 botella de vino al día, sin emborracharse, es ingresado al hos- pital. Evoluciona con malestar general, ansiedad y luego desorientación, asociada a alu- cinaciones zoomorfas de pequeños animales que lo atacan. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Haloperidol
B) Lorazepam
C) Tiamina
D) Carbamacepina
E) Setralina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un delirium tremens, por privación de alcohol, que se trata con diazepam, aun- que en el daño hepático, se prefiere el alprazolam.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 70 5.01.1.028 · Trastorno por déficit aten

Una mujer de 30 años, ingeniera civil, refiere que desde su infancia se le pierden con frecuencia las cosas y que le es diFcil realizar tareas, en especial porque las procras8na y le cuesta terminarlas una vez iniciadas. Por ello realiza listas de todas las cosas que debe hacer a modo de cumplir con ellas. Recientemente, en su trabajo ha aumentado su carga laboral y responsabilidades, lo que la 8ene agobiada y angus8ada. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Trastorno del espectro au2sta
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de personalidad
D) Trastorno por déficit atencional hiperac2vo
E) Trastorno de angus2a generalizada

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un TDAH clásico, de alta capacidad (logró ser ingeniera). Se maneja con técnicas de trabajo y, en algunos casos, fármacos estimulantes como el meGlfenidato y anfetaminas (ej. lisdexanfetamina).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 155 5.01.1.028 · Trastorno por déficit aten

Una paciente de 27 años consulta por ansiedad y ánimo bajo. Refiere antecedentes de problemas de inquietud psicomotora durante la infancia y se considera olvidadiza y desordenada. Refiere que recientemente cambió de puesto de trabajo, presentando errores y dificultades, lo que le ha generado problemas, sintiéndose ansiosa y con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional de tipo hiperactivo
B) Trastorno de personalidad
C) Trastorno de ansiedad social
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Trastorno bipolar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Déficit Atencional en Adultos: Este audio describe un cuadro clínico compatible con déficit de atención del adulto de tipo hiperactivo, con síntomas depresivos y ansiosos.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 176 5.01.1.028 · Trastorno por déficit aten

Universitaria con dificultad para prestar atención, historia de dificultad para concretar tareas y para seguir el hilo de conversación. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno depresivo mayor
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno del espectro autista (TEA)
E) Trastorno por déficit de atención (TDA)

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno por déficit de atención (TDA)** (opción **E**). Trastorno por déficit de atención (TDA). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 86 5.01.1.028 · Trastorno por déficit aten

Un paciente de 25 años presenta mal rendimiento en la universidad, habiendo reprobado una de las asignaturas. Refiere que no se concentra en sus estudios y que no alcanza a leer toda la materia. En la entrevista se ve verborreico, inquieto y teatral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno histriónico de la personalidad
B) Déficit atencional
C) Trastorno bipolar
D) Insuficiencia intelectual leve
E) Síndrome de Asperger

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Déficit atencional** (opción **B**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 111 5.01.1.028 · Trastorno por déficit aten

Un hombre de 40 años acaba de terminar su tercer matrimonio, por lo que está pasando por un mal momento. Tiene además algunos problemas en su trabajo y su historial académico, laboral y también familiar siempre ha tenido dificultades. Como antecedente, refiere que cuando niño sufrió un accidente en que él resultó herido y su padre falleció. Él refiere que no le gustan los desafíos a largo plazo, y prefiere enfocarse en tareas a corto plazo, ya que las cosas a largo plazo no le resultan bien. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de personalidad evitativo
B) Trastorno de conducta
C) Trastorno por déficit atencional
D) Trastorno de estrés postraumático
E) Ciclotimia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece un trastorno por déficit atencional del adulto, aunque era una pregunta algo rara. Además, parecía que actualmente tenía algún grado de trastorno de personalidad, aunque no era evitativo (para empezar se casó 3 veces).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 92 5.01.1.028 · Trastorno por déficit aten

Una adolescente de 18 años consulta ambulatoriamente porque se siente ansioso y agobiado. Además, refiere sentirse bastante avergonzado del mal rendimiento que ha tenido en su primer año de universidad, por lo que ha pensado en cambiarse de carrera, debido a que siente que ya no le gusta tanto lo que eligió estudiar. Refiere que en el colegio siempre había sido buena alumna, aunque reconoce que le costaba concentrarse y que, actualmente, procrastina sus estudios. Con frecuencia pierde las llaves y su celular y se distrae en las conversaciones cara a cara cuando son muy largas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno de ansiedad social
C) Trastorno depresivo mayor
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno adaptativo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno bipolar** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 69 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Un hombre encuentra a su pareja en su casa desorientada y con una ac8tud agresiva y agitada, por lo que la lleva al servicio de urgencia. Al examen Fsico presenta sudoración profusa y sus signos vitales muestran presión arterial 170/110 mmHg, frecuencia cardíaca 160 por minuto y temperatura 38,1 °C. En el examen neurológico se aprecia desorientada en 8empo y espacio, con agitación psicomotora y pupilas midriá8cas isocóricas. ¿Qué sustancia ingirió con mayor probabilidad?

A) Barbitúricos
B) Canabinoides
C) Anfetaminas
D) Órganofosforados
E) Opiáceos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome adrenérgico: midriasis, taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia. La cocaína y las anfetaminas son las clásicas causas.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 18 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Un paciente de 23 años, con retraso mental severo, en tratamiento con clorpromacina, sube la dosis de este medicamente de 100 a 300 mg al día, evolucionando con agitación psicomotora, confusión, boca seca, palpitaciones y malestar general. Su examen físico muestra FC: 115x', PA: 130/90 mmHg, pupilas con midriasis. El diagnóstico más probable es un síndrome:

A) Anticolinérgico
B) Adrenérgico
C) Serotoninérgico
D) Colinérgico
E) Neuroléptico maligno

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los antipsicóticos producen 1. Síndrome neuroléptico maligno y 2. Síndrome anticolinérgico. Las clínicas de todos estos síndromes se preguntan y están descritas en la clase respectiva de intoxicaciones (psiquiatría). En este caso es un síndrome anticolinérgico clásico.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 120 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Un paciente de 20 años, con diagnóstico de trastorno bipolar, en tratamiento con risperidona y litio, desde hace 3 meses, consulta por un cuadro de una semana de evolución de náuseas, malestar general y tendencia al sopor. Al examen físico se constata desorientado, con temblor de extremidades superiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca litemia de 2,2 mEq/L (rango normal: 0,6 a 1,2 mEq/L) y creatininemia: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Plasmaféresis
B) Hemodiálisis
C) Alcalinizar la orina
D) Administrar suero fisiológico endovenoso
E) Diazepam endovenosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Administrar suero fisiológico endovenoso** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 139 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Paciente usuario de cocaína y en tratamiento con carbamazepina por epilepsia. Llega a urgencias con agitación, taquicardia y midriasis. ¿Cuál es el examen de urgencia más relevante a solicitar?

A) Niveles séricos de carbamazepina y ECG
B) TAC de cerebro
C) Ecografía abdominal
D) Radiografía de tórax
E) Hemograma y VHS

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cocaína + carbamazepina: riesgo de interacción (cocaína aumenta niveles de carbamazepina) y toxicidad cardíaca (QRS ancho, arritmias). Urgencia: ECG para evaluar arritmias + niveles de carbamazepina.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 126 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Paciente usuaria de litio en sopor profundo, litemia de 2,6 mEq/L. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Lavado gástrico y carbón activado
B) Solución salina 0,9% endovenosa
C) Suspender litio y observar
D) Diuresis forzada con furosemida
E) Hemodiálisis de urgencia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Hemodiálisis de urgencia** (opción **E**). Hemodiálisis de urgencia. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 174 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Una paciente de 25 años, diagnosticada de depresión en tratamiento, hace algunas horas consume múltiples comprimidos de amitriptilina y evoluciona con desorienta- ción, midriasis y taquicardia. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar su enfren- tamiento?

A) Electrocardiograma
B) Radiografía de tórax
C) Creatina fosfoquinasa
D) Electroencefalograma
E) Pruebas hepáticas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Electrocardiograma** (opción **A**). La intoxicación con tricíclicos produce taquicardias ventriculares, que es lo más grave.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 9 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Un paciente de 78 años, con patologías psiquiátricas en tratamiento con diazepam, sertralina y clorpromazina, presenta un cuadro de 24 horas de evolución de confusión y desorientación, asociado a náuseas, vómitos y sudoración. Al examen físico tiene taquicardia de 115x', hipertensión arterial de 170/110 mmHg, aumento del tono muscular, y sopor superficial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome neuroléptico maligno
B) Síndrome de discontinuación de antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
C) Síndrome de privación de benzodiacepinas
D) Síndrome serotoninérgico
E) Síndrome anticolinérgico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil. El diazepam da síndrome narcótico. La sertralina, síndrome serotoninérgico. La clorpromazina, síndrome neuroléptico maligno y síndrome anticolinérgico. La clínica sugiere síndrome serotoninérgico, que mezcla elementos del síndrome neuroléptico maligno (hipertonía, hipertermia y compromiso de conciencia), con el síndrome adrenérgico (HTA, taquicardia, hipertermia).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 61 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Un paciente de 24 años, con antecedente de retraso mental severo, en tratamiento con clorpromazina, aumenta la dosis de 100 mg al día, a 300 mg al día. Evoluciona con mayor agresividad, asociada a retención urinaria y constipación. Al examen destacan mucosas secas y midriasis. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome colinérgico
B) Síndrome anticolinérgico
C) Síndrome neuroléptico maligno
D) Síndrome serotoninérgico
E) Síndrome adrenérgico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un síndrome anticolinérgico clásico (compromiso de conciencia, retención urinaria, constipación, midriasis, sequedad de mucosas y taquicardia). El colinérgico tiene vómitos, miosis, bradicardia, temblor, contracturas musculares y dificultad respiratoria: ej. organofosforados). El neuroléptico maligno se caracteriza por compromiso de conciencia, hipertermia e hipertonía. El serotoninérgico tiene HTA, aumento del tono muscular, vasoconstricción periférica, compromiso de conciencia. El adrenérgico tiene HTA, taquicardia, hipertermia, midriasis, temblor.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 1 5.01.2.003 · Intoxicación por sustancia

Una paciente de 51 años, con antecedente de artriris reumatoide de larga data, presenta aumento significativo de sus síntomas, con intenso dolor articular y artritis de mpultiples articulaciones en manos, muñecas y tobillos, además de rigidez articular marcada, desde hace cerca de 3 semanas. Mane sus síntomas con celecoxib, naproxeno y tramadol. Evoluciona hace dos días con malestar general y deposiciones oscuras. Dos días después es encontrada por sus familiares en malas condiciones y comprometida de conciencia. Al examen físico, está soporosa, pálida, con FC: 120x' y PA: 80/40, sin otras alteraciones adicionales. ¿Cuál es la causa más probable de su cuadro actual?

A) Leisón de Dieulafoy
B) Intoxicación por opiáceos
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Úlcera gastroduodenal
E) Gastropatía crónica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Intoxicación por opiáceos). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Leisón de Dieulafoy, Síndrome de Mallory Weiss) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 125 5.01.3.011 · Prevención: Alcohol, tabac

Una paciente de 45 años, fumadora de 25 paquetes-año, fuma al despertarse, y fuma más durante la mañana, con grandes bocanadas. Evita lugares donde no se puede fumar y fuma a pesar de enfermarse. La ansiedad es el principal desencadenante para furmar. Ella refiere que no desea dejar de fumar. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Vareniclina
B) Bupropión oral
C) Parches de nicotina
D) Tratar la ansiedad
E) Entrevista motivacional

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un claro diagnóstico de tabaquismo. Sin embargo, está en etapa precontemplativa, porque no quiere dejar de fumar. Por ello, la única opción es tratar los desencadenantes.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 129 5.01.1.004 · Trastorno de adaptación

Un paciente de 35 años refiere sensación de angustia e inquietud, de un mes de evolución, asociado a insomnio de conciliación y cefalea diaria, de localización occipital, que se irradia hacia los hombros. Refiere que los síntomas iniciaron en relación a la necesidad de cambiarse de casa, ya que fue asignado a nuevo cargo en su trabajo, en una ciudad distinta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por somatización
B) Depresión mayor
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un trastorno adaptativo clásico de tipo ansioso (gatillante claro y síntomas ansiosos). Si bien tiene síntomas somáticos (cefalea tensional) no es un trastorno de somatización (múltiples síntomas de todo tipo).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 90 5.01.1.004 · Trastorno de adaptación

Una mujer de 45 años consulta por irritabilidad, ánimo triste y sensación de agobio de dos meses de evolución, iniciados tras la separación de su pareja. Refiere llanto ocasional, dificultad para dormir y disminución en su rendimiento laboral, aunque con8núa asis8endo a su trabajo y man8ene sus ac8vidades co8dianas. Refiere que se siente mejor cuando hace ejercicio y 8ene ac8vidades sociales, pero que se siente sola y triste cuando regresa a su casa. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Episodio depresivo mayor
B) Trastorno adapta2vo
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Sana PARTE 2

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta que no estaba originalmente en el Eunacom y que fue añadida para efectos prácticos. Es un trastorno adaptativo de Gpo depresivo, con un gaGllante claro y síntomas anímicos. No alcanza a cumplir criterios de depresión mayor, aunque este es el diagnóstico diferencial más importante en este caso.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 167 5.01.1.004 · Trastorno de adaptación

Paciente con angustia e insomnio de conciliación luego de enterarse que debe cambiarse de ciudad por trabajo. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno depresivo mayor
C) Trastorno adaptativo
D) Trastorno por estrés agudo
E) Trastorno de pánico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno adaptativo** (opción **C**). Trastorno adaptativo. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 128 5.01.1.004 · Trastorno de adaptación

Un paciente de 28 años presenta ánimo bajo e irritable, desde hace 2 meses, fecha en que murió su hermano. Se siente ansioso e intranquilo, sin cambios en el peso. Los síntomas interfieren moderadamente con sus actividades laborales. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de estrés agudo
B) Trastorno de adaptación
C) Episodio depresivo mayor
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Distimia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un T. adaptativo clásico (gatillante claro, síntomas depresivos y/o ansiosos, pero sin cumplir criterios de depresión u otro trastorno ansioso: ej. no tiene cambios en el peso ni afectación grave de su vida).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 108 5.01.1.004 · Trastorno de adaptación

Un hombre de 43 años consulta porque, desde hace 15 días, ha presentado angustia, desasosiego, insomnio y malestar general. Refiere, además, cefalea occipital, irradiada al cuello que es peor en las tardes. Refiere que los síntomas iniciaron después de que le comunicaron en su trabajo que sería trasladado a otra cuidad, por lo que deberá cambiarse de casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de somatización
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de adaptación
D) Trastorno de angustia
E) Episodio depresivo mayor

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno de adaptación** (opción **C**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 155 5.01.1.004 · Trastorno de adaptación

Hombre de 30 años que presenció un accidente de tránsito grave en que su mejor amigo resultó herido de gravedad. Desde entonces, hace 2 semanas, presenta insomnio, tristeza, dificultad de concentración en el trabajo y anhedonia. Sin ideación suicida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de pánico
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno adaptativo
D) Depresión mayor
E) Trastorno de estrés agudo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Trastorno adaptativo: síntomas emocionales/conductuales dentro de los 3 meses de un estresor identificable (accidente del amigo), con deterioro funcional pero sin cumplir criterios de depresión mayor (necesita ≥5 síntomas por ≥2 semanas con humor depresivo o anhedonia). Resolución espontánea esperada.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 142 5.01.1.004 · Trastorno de adaptación

Paciente pierde el trabajo hace 4 semanas, y hace 3 semanas inicia con los siguientes síntomas: subido de peso y tenía insomnio, pero después decía sin anhedonia - depresión o distimia?

A) Trastorno adaptativo porque no cumplia el mes para ser depresivo (ojo que sd. depresivo se
B) Trastorno depresivo mayor
C) Interrupción del embarazo
D) Maduración pulmonar y observación
E) Cesárea de urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Trastorno adaptativo porque no cumplia el mes para ser depresivo (ojo que sd. depresivo se). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 163 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Una paciente de 22 años es hospitalizada por un cuadro de diarrea, vómitos y dolor abdominal de difícil manejo. Durante la hospitalización es sorprendida ingiriendo laxantes, autoinduciéndose vómitos y adulterando la temperatura del termómetro. Se solicitan exámenes, descartándose patología orgánica. Además, luego de indagar, no se encuentra ninguna ganancia evidente con estos síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno delirante
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de la conducta alimentaria

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un trastorno facticio clásico, del tipo Múnchausen, ya que se autoprovoca síntomas (no solo los finge). No tiene ganancias económicas (así que no es simulación, sino facticio, cuya ganancia es afectiva, aunque no se muestre en la pregunta).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 102 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Un paciente presenta dolor abdominal y vómitos desde hace 5 días, y tiene una actitud muy demandante y agresiva, solicitando la realización de exámenes y administración de medicamentos. En una ocasión fue sorprendido tomando laxantes y adulterando la temperatura del termómetro. Además, hace un año estuvo hospitalizado por un cuadro similar, hecho que él no refirió en la consulta. Al indagar un poco más, se concluye que no tiene una causa orgánica que explique sus síntomas, pero que tampoco hay una ganancia evidente para él. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por hipocondría
B) Trastorno de somatización
C) Trastorno delirante crónico
D) Episodio psicótico breve
E) Trastorno facticio

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno facticio** (opción **E**). Al hacerlo intencionalmente, es un trastorno facticio clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 131 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Un paciente de 46 años presenta múltiples síntomas, como cefalea, molestias abdominales, calambres, astenia, entre otros, desde hace un año. Se han realizado múltiples exámenes, sin encontrar una causa orgánica. Llama la atención que ha tenido proteinuria persistente, que no se correlaciona con el cuadro clínico, ni con los demás exámenes, por lo que se tienen fuertes sospechas de que ha manipulado las muestras de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno facticio
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno hipocondriaco

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno facticio** (opción **C**). La sospecha de manipulación de los exámenes, hace que sea facticio.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 172 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Un paciente de 57 años presenta múltiples síntomas difíciles de precisar. Se ha realiza múltiples exámenes y evaluaciones médicas, sin poder llegar a un diagnóstico. Sin embargo, él insiste en que está muy enfermo y no puede realizar actividades básicas, como asearse. Hace 2 años fue pensionado por esto, sin cambiar su conducta. Su esposa lo cuida y lo asiste abnegadamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por simulación
B) Trastorno hipocondríaco
C) Trastorno de somatizaicón
D) Trastorno facticio
E) Trastorno de personalidad dependiente

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Que se haya pensionado hace sospechar un T. por simulación, pero que no cambie su conducta y que su vida esté tan afectada, hace sospechar más un T. facticio. También el hecho de que su mujer lo cuide abnegadamente (fin ganancial de afecto, atención y cuidados).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 47 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Una paciente de 30 años, diabética tipo 1, con historia de 5 hospitalizaciones en el último año por cuadros de hipoglicemia severa. Actualmente ingresa en shock hipogli- cémico, el que es manejado adecuadamente. Durante su hospitalización, es sorprendida en el baño inyectándose una dosis de insulina que no le correspondía, lo cual ella poste- riormente niega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disociativo
B) Trastorno somatomorfo
C) Trastorno hipocondriaco
D) Trastorno por simulación
E) Trastorno facticio

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno facticio** (opción **E**). Es un trastorno facticio clásico. No es por simulación, porque no hay un fin económico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 85 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Una joven que consulta por diarrea de meses, exige que la hospitalicen para estudio. Estudio normal. La pillan tomando laxantes, ella lo niega, no se sabe motivo por el que hace esto. ¿Cual es el diagnóstico? a. Trastorno facticio

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hemograma y VHS** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 131 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Una paciente de 19 años, ha sido hospitalizada 8 veces por hipoglicemias, sin una causa clara, que han requerido hospitalización y que se resuelven fácilment

E) En la última hospitalización, fue sorprendida inyectándose una dosis de insulina en el baño. Sin embargo, ella niega abiertamente este hecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disociativo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno somatomorfo
D) Trastorno facticio

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (En la última hospitalización, fue sorprendida inyectándose una dosis de insulina en el baño. Sin embargo, ella niega abiertamente este hecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 34 5.01.1.022 · Trastornos facticios

Un paciente de 50 años relata que, al llegar a su trabajo en auto, se le “descompuso el cuerpo”, sintiendo rigidez generalizada en todos sus músculos, lo que le impidió entrar a su trabajo y lo obligó a devolverse a su casa. Además, presentó pérdida de conciencia con movimientos repetitivos en su casa, razón por la cual fue llevado al servicio de urgencias. Refiere malestar, angustia y desasosiego de varios días de evolución. Al examen físico tiene un examen neurológico estrictamente normal y su resonancia magnética nuclear descarta lesiones. Sus familiares refieren que siempre ha sido un buen trabajador y excelente padre, por lo que no entienden bien qué le está pasando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno depresivo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno adaptativo
D) Trastorno facticio
E) Trastorno disociativo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno facticio** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 104 5.01.1.036 · Trastorno de ansiedad gene

Una mujer de 30 años se preocupa mucho por las finanzas y la salud de su familia. Además, le angustia que alguno de sus familiares pudiera quedarse sin trabajo o que la economía decayera. Refiere estar pasando por un periodo de estrés laboral y estar estresada porque muchas cosas dependen de ella, tanto en su trabajo, como en su familia. Refiere que en el último tiempo, lo único que la mantiene más tranquila es tomar un poco de clonazepam, el que consume 2 a 3 veces por semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno obsesivo compulsivo
B) Trastorno de pánico
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Reacción adversa a las benzodiazepinas
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno de ansiedad generalizada** (opción **E**). Tiene distinas preocupaciones, de distintos tipos, por lo que es un TAG clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 109 5.01.1.036 · Trastorno de ansiedad gene

Un paciente de 40 años consulta por desasosiego e insomnio de conciliación de 2 meses de evolución. Refiere estar especialmente preocupado por su situación laboral y por el estado de la economía del país. Niega pensamientos suicidas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Trastorno adapta2vo
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de estrés agudo
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno de angus2a

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, porque entrega muy poca información. Sin embargo, el cuadro probablemente es un TAG (expectación ansiosa, con múlGples preocupaciones).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 143 5.01.1.036 · Trastorno de ansiedad gene

Mujer que ha sido muy aprehensiva con los estudios y preocupada por su familia, pareja y relaciones amorosas, al punto de estar todo el tiempo estresada y con problemas digestivos , ella refiere sentirse asi desde la perdida de su abuelo (que murió hace 5 años), los padres refieren que ha sido asi desde chica:

A) Trastorno ansiedad generalizada b. Ts de la personalidad obsesivo compulsivo? (Porque no puede ser esta, considerando que es “una forma de ser” desde muy pequeña?)
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno de estrés postraumático
E) Episodio depresivo mayor

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Trastorno ansiedad generalizada b. Ts de la personalidad obsesivo compulsivo? (Porque no puede ser esta, considerando que es “una forma de ser” desde muy pequeña?)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 113 5.01.1.035 · Consumo perjudicial de dro

¿Cuál es el riesgo principal del consumo de marihuana entre los 12 y los 18 años de edad?

A) Riesgo de dependencia a la marihuana
B) Riesgo de intoxicación aguda
C) Desarrollo de esquizofrenia
D) Disminución de la motivación escolar
E) Desarrollo de alcoholismo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Disminución de la motivación escolar). Pregunta difícil.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 82 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Paciente de 35 años con episodios previos de tristeza profunda de 3 semanas de duración. Ahora consulta por irritabilidad, euforia, grandiosidad, insomnio sin cansancio y gastó todos sus ahorros en 4 días. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trastorno bipolar tipo I
B) Trastorno depresivo mayor recurrente
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno de personalidad borderline

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Episodios depresivos previos + episodio maníaco actual (grandiosidad, insomnio, gastos impulsivos, euforia) = trastorno bipolar tipo I. Un episodio maníaco es suficiente para el diagnóstico.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 77 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Un paciente de 22 años es traído por sus familiares debido a que anda muy irritable y con una ac8tud rara, además de haber iniciado una serie de proyectos de negocios nuevos. Al examen presenta aceleración del habla y sus acompañantes comentan que en ocasiones trabaja hasta muy tarde, pese a lo cual al día siguiente con8núa con sus ac8vidades normales, durmiendo muy pocas horas. Durante la entrevista, en ocasiones se emociona y llora y en otras se ríe a carcajadas. Sus compañeros de estudios refieren que anda más gracioso y “sin filtro”. Tiene antecedente de haberse deprimido a los 18 años en relación con una ruptura sen8mental. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Trastorno adapta2vo mixto
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno por déficit atencional hiperac2vo
D) Trastorno de personalidad en crisis
E) Trastorno esquizoafec2vo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un trastorno afectivo bipolar clásico. Ahora está en episodio maníaco, cuya presencia confirma el diagnóstico de trastorno bipolar. El antecedente de depresión lo refuerza.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 92 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Paciente con trastorno bipolar tipo I presenta episodio de manía aguda con agitación, desinhibición y grandiosidad. ¿Cuál es el tratamiento de elección en fase aguda?

A) Litio + antipsicótico atípico (quetiapina u olanzapina)
B) Solo antidepresivos ISRS
C) Benzodiacepinas en monoterapia
D) Lamotrigina en dosis progresiva
E) Ácido valproico en monoterapia oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Manía aguda: tratamiento combinado con estabilizador del ánimo (litio o ácido valproico) más antipsicótico atípico para control rápido de síntomas. Litio + quetiapina es esquema estándar.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 114 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Una paciente de 23 años presenta un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por ánimo bajo, tristeza, disminución de sus actividades, asociado a hipersomnia diurna y aumento de peso de 5 kg en poco tiempo. Además, refiere dificultades de concentración en sus actividades educacionales. Tiene antecedentes de tres episodios similares en los últimos años y su hermana refiere que también ha presentado dos episodios en los cuales ha tenido periodos con mucho ánimo y aumento de la energía, incurriendo en gastos excesivos y desarrollando múltiples proyectos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad histriónico
B) Trastorno afectivo bipolar
C) Trastorno por déficit atencional hiperactivo
D) Trastorno de personalidad limítrofe
E) Depresión atípica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno Afectivo Bipolar: La paciente presenta un cuadro inicial que podría interpretarse como una depresión atípica, con aumento de peso e hipersomnia. Sin embargo, el antecedente de episodios maníacos previos apunta a trastorno afectivo bipolar. En el contexto de un trastorno bipolar, la depresión debe tratarse con antipsicóticos atípicos como la risperidona o el aripiprazol, y eventualmente con estabilizadores del ánimo como el litio o el ácido valproico.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 34 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Un paciente de 22 años es traído por sus familiares, dado que anda muy irritable y ha iniciado una serie de proyectos de negocio, en áreas que no maneja bien. Presenta aceleramiento del habla y hay noches en las que pasa sin dormir, a pesar de lo cual, al día siguiente no presenta sueño. En ocasiones, se ríe a carcajadas y ,en otras, se emociona fácilmente al hablar de ciertos temas. Sus amigos lo describen como “patudo y sin filtro”. Tiene antecedente de haberse deprimido hace algunos años, en relación a una ruptura sentimental. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno esquizoafectivo
B) Trastorno adaptativo mixto
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno de personalidad en crisis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una manía clásica y, por tanto, un TAB. No tiene síntomas psicóticos. Si bien la personalidad parece estar afectada (ser "patudo y sin filtro"), no hay duda que de base hay un TAB.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 165 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Paciente con irritabilidad, conductas sexuales de riesgo, disminución de necesidad de dormir, más habladora de lo habitual. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad histriónica
B) Trastorno bipolar (episodio maníaco)
C) Trastorno por déficit atencional
D) Hipomanía inducida por sustancias
E) Trastorno ciclotímico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno bipolar (episodio maníaco)** (opción **B**). Trastorno bipolar (episodio maníaco). El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 130 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Un paciente de 27 años presenta ánimo bajo, anhedonia y desconcentración, asociado a baja de peso y dificultades para dormir, por lo que se le indica tratamiento con sertralina 50 mg al día. Evoluciona con clara mejoría de los síntomas, sin embargo, su pareja refiere que anda más irritable, ha aumentado el gasto de dinero y ha iniciado nuevos proyectos. Suspende el medicamento, persis8endo con disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad y verborrea. ¿Qué fármaco es más adecuado para su manejo actual?

A) Sertralina
B) Mirtazapina
C) Bupropión
D) Diazepam
E) Que2apina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Viró a una hipomanía, en contexto de un trastorno bipolar que no había sido diagnosticado. Están contraindicados todos los antidepresivos (setralina, mirtazapina, bupropión). El tratamiento de elección es con antipsicóticos aVpicos (ej. queGapina, risperidona, aripiprazol u olanzapina) en la hipomanía, y con antipsicóticos aVpicos más estabilizadores del ánimo clásicos (liGo y ácido valproico) en las manías. Luego se mantiene con dichos fármacos a permanencia.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 13 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Un paciente de 20 años inicia tratamiento con fluoxetina, por un cuadro de ansiedad social, evolucionando con aumento de la sociabilidad, volviéndose muy conversador, pero siendo en ocasiones muy intrusivo, al punto de ser desagradable. Muestra ausencia de empatía y ha tenido problemas con sus compañeros de estudios. Con frecuencia, se muestra irritable, ansioso y a veces emocionado, con llanto. Ha aumentado su nivel de actividad física y, además, presenta disminución de las horas de sueño, sin disminuir su nivel de energía. En ocasiones, presenta ganas de salir corriendo, sin saber por qué. Tiene antecedente de un episodio depresivo a los 16 años, que respondió al tratamiento con sertralina. El diagnóstico más probable es un trastorno:

A) Bipolar
B) Adaptativo mixto
C) Por déficit atencional
D) Esquizoafectivo
E) Delirante

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Bipolar** (opción **A**). Tiene una manía clásica, secundaria al uso de fármacos y, por tanto, tiene un TAB.. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 128 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Un paciente de 19 años, estudiante universitario, inicia sertralina oral, debido a un trastorno de ansiedad social. Evoluciona con verborrea e hiperactividad, le habla a personas con las que normalmente no conversaba y se muestra muy inquieto y optimista. No se observa cansado, a pesar de dormir poco. Como antecedente, tuvo una depresión diagnosticada a los 18 años, que respondió al tratamiento antidepresivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno esquizoafectivo
C) Trastorno esquizotípico de la personalidad
D) Distima
E) Trastorno por déficit atencional

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno bipolar** (opción **A**). Tiene una manía aguda, por lo que tiene un trastorno bipolar.. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 35 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Paciente femenina con antecedente de episodio depresivo mayor hace 5 años tratada, nuevamente sintomática, parte antidepresivos y evoluciona con cambios de conducta aumento de energía: a. Bipolar

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno bipolar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Trastorno de ansiedad generalizada** (opción **A**). Intoxicación por litio: vómitos, temblor, ataxia, poliuria; manejo con suero fisiológico y hemodiálisis si grave. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 178 5.01.1.009 · Trastorno bipolar

Una paciente de 23 años, en tratamiento antidepresivo, desde hace 15 días, consul- ta por un cuadro paranoide, asociado a expansividad. Además presenta disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad, agresividad y aumento de la actividad psico- motora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acatisia
B) Esquizofrenia
C) Depresión psicótica
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de personalidad limítrofe

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno bipolar** (opción **D**). Es una manía aguda, en contexto del uso de antidepresivos. Por tanto es un tras- torno bipolar.. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 148 5.01.1.014 · Delirium

Un paciente de 56 años es encontrado inconsciente en la vía pública, con hálito alcohólico, con varios golpes. Se hospitaliza para manejo de sus lesiones, sin embargo, a las 48 horas presenta gran agitación, diciendo que lo tienen encerrado en la cárcel y no lo dejan escapar. Se observa desorientado, tembloroso y no coopera con el interrogatorio. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo?

A) Tiamina
B) Haloperidol
C) Lorazepam
D) Clorpromazina
E) Risperidona

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Tiamina** (opción **A**). Tratamiento demencia: multidisciplinario + evitar estrés del cuidador + donepesilo (inhibidor acetilcolinesterasa, de elección) o memantina. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 24 5.01.1.014 · Delirium

Un paciente de 77 años con enfermedad de Alzheimer inicial, en tratamiento con donepezilo 10 mg durante el día y trazodona 50 mg por la noche, presenta dos semanas de agitación nocturna asociada a la idea de que le están robando. Esto ha generado conflictos con sus cuidadores y, además, no ha permi8do que lo bañen. Desde hace dos días presenta alucinaciones visuales. El resto de su examen Fsico es normal y su examen neurológico no 8ene signos focales. Además de realizar exámenes, en busca de un foco infeccioso, ¿qué fármaco es de elección para su manejo actual?

A) Diazepam
B) Haloperidol
C) Lorazepam
D) Risperidona
E) Amitrip2lina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta difícil y discuGble. Claramente Gene un delirium y hay que darle un antipsicótico. El clásico que se ha usado siempre es el haloperidol, pero los antipsicóticos aVpicos, como la risperidona, cuentan con buena evidencia y seguridad. En Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, se contraindica el haloperidol e incluso la risperidona por el riesgo de síntomas extrapiramidales y la respuesta suele ser queGapina. En otras demencias, como la enfermedad de Alzheimer, es discuGble, pero muchas guías más modernas se inclinan más a los antipsicóticos aVpicos, como la risperidona (por eso la dejaremos como correcta), a menos que sea un cuadro de agitación muy severo, en que se sigue usando el haloperidol.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 168 5.01.1.014 · Delirium

Una paciente de 78 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es hospitalizada tras desorientarse y agredir a sus cuidadores. En el examen mental se encuentra desorientada en tiempo y espacio, no puede decir los días de la semana en orden inverso y no es capaz de recordar tres palabras que se le dicen en voz alta. Dice ver a su padre en la habitación y, tras el ingreso al hospital, comienza a gritar, exigiendo que la suelten y que se quiere ir del hospital. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo inicial?

A) Clonazepam
B) Carbamazepina
C) Haloperidol
D) Mirtazapina
E) Diazepam

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo del Delirium: El tratamiento principal del delirium o síndrome confusional agudo es abordar la causa subyacente. El manejo sintomático puede incluir haloperidol en dosis bajas (0,5 a 1 mg) por vía oral o intramuscular.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 37 5.01.1.014 · Delirium

Un paciente se hospitaliza hace 48 horas, por un traumatismo, secundario a un accidente de tránsito. Como antecedente, toma 1 botella de vino al día, sin llegar a la ebriedad. Al segundo día de ingreso presenta un cuadro de agitación psicomotora, desorientación temporoespacial, temblor y alucinaciones visuales zoomórficas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Haloperidol
B) Lorazepam
C) Risperidona
D) Carbamacepina
E) Tiamina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un delirium tremens clásico, que se trata con benzodiacepinas, en especial el diazepam. El lorazepam también es útil y es el de elección en el DHC.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 149 5.01.1.013 · Dependencia de otras droga

Un paciente consulta porque quiere dejar de fumar. Fuma cerca de 10 cigarrillos al día, especialmente cuando está más nervioso, los fines de semana y en las reuniones sociales. Disfruta del cigarrillo y no cree que podrá dejar de fumar sin apoyo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?

A) Terapia cognitiva conductual
B) Parches de nicotina
C) Bupropión
D) Fluoxetina
E) Vareniclina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La base del tratamiento de todas las adicciones es la TCC. Además, en fumadores de menos de 15 cigarrillos al día suele ser la única intervención necesaria, ya que no suelen tener dependencia física a la nicotina. Sobre esa cantidad, a la TCC se le suele agregar sustitución con nicotina (si muchos síntomas de abstinencia) y bupropión o vareniclina (si mucho deseo de fumar).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 1 5.01.1.023 · Trastorno del espectro aut

Un paciente de 20 años presenta episodios de descontrol y agresividad, en los que rompe objetos, grita, amenaza con agredir y con autoagredirse. Se molesta mucho cuando le cambian sus cosas de lugar y tiene rutinas muy marcadas, las que le cuesta mucho modificar. Abandonó la secundaria, ya que reprobó dos veces primero medio. Además, tiene muy buena memoria, al punto que puede memorizar los códigos de barras de distintos productos. Desde niño que fue considerado como raro, no entablaba amistades y jugaba solo siempre con el mismo juguete, además de ver repetidamente sus dos películas favoritas. Saluda a las personas de una manera extraña, con aleteo de sus extremidades superiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno del especto autista
E) Trastorno estereotipado del movimiento

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un TEA clásico del adulto, con rigidez cognitiva, intereses restringidos, alteraciones sociales, estereotipias más escasa autorregulación, seguramente por estar mal manejado.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 105 5.01.1.023 · Trastorno del espectro aut

Niño de 3 años con antecedente de autismo. Presenta episodios de golpear su cabeza contra la pared repetidamente, varias veces al día. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a psiquiatría infantil para evaluación y manejo conductual
B) Hospitalizar de urgencia
C) Iniciar haloperidol
D) Solicitar EEG para descartar epilepsia
E) Solo observar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conductas autolesivas en niño con TEA (autismo): derivar a psiquiatría infantil + equipo de terapia conductual (ABA). Las conductas repetitivas y autolesivas son parte del espectro autista y requieren manejo especializado.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 87 5.01.1.029 · Intento de suicidio en niñ

Una adolescente de 15 años se intenta suicidar, ingiriendo 600 miligramos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo?

A) Gases arteriales
B) Bilirrubinemia
C) Electrocardiograma
D) Creatinfosfoquinasa
E) Pruebas hepáticas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Electrocardiograma). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Gases arteriales, Bilirrubinemia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 132 5.01.1.005 · Trastorno agudo por estrés

Paciente que presenció un asalto hace 2 semanas, ahora con angustia, irritabilidad, insomnio y estado de hiperalerta. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
B) Trastorno adaptativo con ansiedad
C) Trastorno por estrés agudo
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno depresivo mayor

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Trastorno por estrés agudo** (opción **C**). Trastorno por estrés agudo. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 94 5.01.3.005 · Higiene del sueño

Enfermera luego de su turnos de urgencia le cuesta dormir y se automedica con diazepam, conducta:

A) Clotiazepam antes de dormir
B) Quetiapina
C) Higiene del sueño/ control ambiental
D) Zolpidem
E) Observación clínica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Higiene del sueño/ control ambiental** (opción **C**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 81 5.01.1.034 · Trastornos del ánimo en ni

Un adolescente de 16 años presenta, desde hace 3 meses, anhedonia, disminución en su rendimiento escolar y presencia de pensamientos negativos sobre sí mismo y su situación, con aislamiento social. Además, relata dificultades para concentrarse en sus actividades académicas e insomnio tanto de inicio como de mantención. Ha subido 5 kilogramos de peso en los últimos meses. Niega autoagresiones y no tiene ideación suicida actual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Distimia
B) Trastorno del espectro autista
C) Episodio depresivo mayor
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno de personalidad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Depresión en Adolescentes: El cuadro clínico corresponde a una depresión o episodio depresivo mayor. La distimia se diagnostica en adolescentes tras un año de ánimo bajo y disforia sin cumplir criterios de depresión. En este caso, sí hay criterios de depresión porque se afecta el peso, el sueño, el rendimiento escolar y la vida social.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 38 5.01.1.031 · Trastorno conducta disocia

Adolescente de 14 años que presenta ausencias repetidas al colegio, peleas con compañeros, robos dentro del hogar y consumo de alcohol desde los 12 años. Los padres refieren que "no respeta ninguna norma". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Discapacidad intelectual
B) TDAH
C) Trastorno de conducta
D) Trastorno del espectro autista
E) Fobia social

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno de conducta: patrón repetitivo y persistente de comportamiento que viola los derechos básicos de otros o normas sociales (agresión, robo, absentismo, consumo de sustancias). Inicio antes de los 15 años. Requiere intervención multidisciplinaria.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 145 5.01.1.031 · Trastorno conducta disocia

En el servicio de urgencias, usted evalúa a un niño de 11 años, que se ha comportado muy agresivo, autoagrediéndose y golpeando a su madre. Ella refiere que fue citada al colegio, debido a que su hijo tenía malas notas y un comportamiento inapropiado. En la entrevista, el director del colegio le comunicó que había insultado y agredido a sus compañeros y a uno de sus profesores. Tras ser confrontado por su madre, el niño procedió a agredirla y luego s infringió cortes en los brazos. Además, su abuela refiere que el niño miente y le ha robado alcohol y cigarrillos de su tienda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disocial
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Trastorno del espectro autista
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno oposicionista desafiante

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno de Conducta Disocial: Este audio describe el trastorno de conducta (o disocial), caracterizado por comportamientos agresivos y crueles que violan las normas sociales y legales. Sin un manejo adecuado, puede evolucionar a un trastorno de personalidad antisocial.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 162 5.01.1.017 · Disfunción sexual

Una paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno orgásmico femenino
B) Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C) Trastorno depresivo mayor
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno del deseo sexual hipoactivo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Dispareunia Superficial: La dispareunia superficial, también conocida como vaginismo o síndrome de dolor genitopélvico penetración, se caracteriza por la contracción involuntaria de los músculos vaginales, causando dolor durante la penetración. Es importante diferenciarla del trastorno orgásmico femenino (ausencia de orgasmo) y el trastorno del deseo sexual hipoactivo (disminución del deseo sexual), que no presentan dolor.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 161 5.01.1.017 · Disfunción sexual

Una paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno orgásmico femenino
B) Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C) Trastorno depresivo mayor
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno del deseo sexual hipoactivo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Dispareunia/Vaginismo: El trastorno por dolor genito-pélvico/penetración (dispareunia superficial o vaginismo) se caracteriza por contracción involuntaria de los músculos vaginales, causando dolor durante la penetración. Difiere del trastorno orgásmico (ausencia de orgasmo) y del deseo hipoactivo (disminución del deseo).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 73 5.01.1.011 · Consumo perjudicial de alc

Una paciente de 35 años es traída al servicio de urgencia debido a que, luego del consumo de alcohol en una fiesta, presentó una ac8tud agresiva peleando con otros invitados, a quienes arrojó vasos de vidrio, por lo que fue re8rada del lugar. Refiere que consume alcohol de manera esporádica, habitualmente solo durante los fines de semana, y que lo hace como una forma de distenderse de su alta carga laboral. En una oportunidad fue detenida por manejar en estado de ebriedad, sin embargo, ella no considera que ello sea un problema. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar disulfiram vía oral
B) Indicar benzodiacepinas vía oral
C) Iniciar bupropión vía oral
D) Realizar entrevista mo2vacional
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Presenta un consumo perjudicial de alcohol con escasa conciencia de enfermedad (etapa precontemplativa), por lo que primero se debe trabajar la motivación al cambio. De nada sirve iniciar fármacos o derivar a psicoterapia, si no Gene intenciones de cambiar.

PEDIATRÍA & NEONATOLOGÍA

Módulo 3: Materno - Infantil · Colección Tomo 18

406 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

116 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.001	Desnutrición	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.004	Adenitis cervical	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · 18.4 (Pág. 11)
2.01.1.005	Celulitis periorbitaria	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 15 · 15.8 (Pág. 26)
2.01.1.006	Coqueluche	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.007	Enteroparasitosis	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.008	Escarlatina	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.009	Exantemas virales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	20 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.010	Hepatitis viral	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.011	Infecciones de piel y partes blandas	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	9 Q	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)
2.01.1.013	Infecciones por Salmonella	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.015	Meningoencefalitis/ Meningitis bacteriana aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · 18.7 (Pág. 24)
2.01.1.016	Mononucleosis infecciosa	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.018	Síndrome febril prolongado	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · 18.10 (Pág. 37)
2.01.1.020	Bronquiolitis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.023	Faringoamigdalitis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.024	Infecciones respiratorias agudas bajas y sus complicaciones	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	9 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.025	Laringitis	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.026	Otitis media	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.027	Resfrío común	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.029	Sinusitis	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.030	Adenopatías	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.031	Anemia ferropriva	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.032	Leucemias	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	4 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.034	Neutropenia febril	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.035	Síndrome purpúrico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.1.036	Trastornos coagulación	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.037	Tumores sólidos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.038	Constipación	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.039	Diarrea aguda y en vías de prolongación	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 18 · 18.11 (Pág. 41)
2.01.1.040	Diarrea crónica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.042	Fibrosis quística	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.043	Hemorragia digestiva	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.046	Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	6 Q	Tomo 18 · 18.12 (Pág. 45)
2.01.1.047	Síndrome disentérico	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.048	Síndrome malabsorción	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.049	Arritmias	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · 18.13 (Pág. 47)
2.01.1.050	Cardiopatías congénitas frecuentes	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.052	Insuficiencia cardíaca	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.054	Soplos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.055	Alergias	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.056	Inmunodeficiencias	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.057	Mesenquimopatías	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.058	Vasculitis: PSH, Kawasaki, otros	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	14 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.060	Hematuria	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.062	Infección urinaria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	12 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.067	Síndrome hemolítico urémico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.1.068	Síndrome nefrítico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · C.5 (Pág. 14)
2.01.1.069	Síndrome nefrótico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.071	Trastornos hidro-electrolíticos	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.072	Alteraciones del desarrollo puberal	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	9 Q	Tomo 18 · C.7 (Pág. 18)
2.01.1.073	Diabetes	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.1.074	Hiperplasia suprarrenal congénita	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 18 · C.9 (Pág. 22)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.075	Hipotiroidismo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · C.10 (Pág. 24)
2.01.1.076	Talla baja	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 18 · C.11 (Pág. 26)
2.01.1.077	Cefalea	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · C.12 (Pág. 28)
2.01.1.078	Encefalopatía hipóxico-isquémica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.1.081	Síndrome convulsivo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · C.16 (Pág. 36)
2.01.1.083	Síndrome hipertónico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 18 · 18.2 (Pág. 7)
2.01.1.085	Trastornos aprendizaje	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · C.20 (Pág. 44)
2.01.1.087	Tumores SNC	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.088	Criptorquidia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.089	Fimosis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.090	Hernia inguinal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.092	Displasia de caderas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.093	Infecciones osteoarticulares	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.094	Patología de columna	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.095	Conjuntivitis aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.096	Estrabismo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.103	Rinitis alérgica	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.105	Alteraciones pigmentarias	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.107	Dermatitis atópica	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.108	Dermatitis del pañal y de contacto	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.109	Ectoparasitosis	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.111	Malformaciones vasculares cutáneas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.112	Alteraciones de la termorregulación	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.115	Convulsiones neonatales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.116	Enterocolitis necrotizante (ECN)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.117	Estridor congénito	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.120	Hipoglicemia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · 18.19 (Pág. 68)
2.01.1.121	Ictericia neonatal y del primer trimestre	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 18 · 18.17 (Pág. 60)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.1.123	Prematurez	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.124	Sepsis neonatal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.125	Síndrome aspirativo meconial	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.126	Síndrome distress respiratorio	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · 18.18 (Pág. 64)
2.01.1.127	TORCH	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.128	RN PEG-GEG	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 18 · 18.16 (Pág. 58)
2.01.1.131	Sinequias vulvares	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.132	Dismorfias	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.133	Malformaciones congénitas más frecuentes	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.138	Maltrato infantil	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.1.141	Trastornos del desarrollo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.2.003	Aspiración cuerpo extraño	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 18 · 18.8 (Pág. 28)
2.01.2.005	Crisis bronquial obstructiva	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · C.6 (Pág. 16)
2.01.2.006	Deshidratación	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	3 Q	Tomo 18 · 18.14 (Pág. 49)
2.01.2.010	Hemorragia digestiva	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · C.1 (Pág. 6)
2.01.2.011	Hipertensión endocraneana	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · C.2 (Pág. 8)
2.01.2.013	Insuficiencia respiratoria aguda	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · C.4 (Pág. 12)
2.01.2.014	Intoxicaciones	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 18 · C.19 (Pág. 42)
2.01.2.015	Meningitis bacteriana	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Tomo 18 · C.8 (Pág. 20)
2.01.2.017	Muerte súbita-ALTE, BRUE	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · C.13 (Pág. 30)
2.01.2.019	Obstrucción intestinal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 18 · C.25 (Pág. 54)
2.01.2.022	Quemaduras	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · C.28 (Pág. 60)
2.01.2.023	Shock	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · C.29 (Pág. 62)
2.01.2.024	Síndrome convulsivo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · C.30 (Pág. 64)
2.01.2.144	SARS Cov 2 COVID 19	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.3.001	Alimentación normal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · 18.15 (Pág. 54)
2.01.3.002	Desarrollo psico-motor	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.3.003	Diagnóstico nutricional	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.3.006	Inmunizaciones en Chile (PNI y extra PNI)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	19 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
2.01.3.007	Lactancia materna	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.3.018	Supervisión de salud- lactante	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.4.003	Ecotomografía abdominal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.5.002	Atención inmediata del recién nacido	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.5.004	Maniobra de Heimlich	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.5.005	Osteoclisis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)
2.01.5.011	Reanimación neonatal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 18 · Pediatría (Pág. 8)

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 6 2.01.1.074 · Hiperplasia suprarrenal co

Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na+ 132, K+ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

A) Vancomicina
B) Noradrenalina
C) Hidrocortisona
D) Vasopresina
E) Dopamina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una hiperplasia suprarrenal congénita, con una crisis adrenal (se ve por la hiponatremia, hiperkalemia y shock que no responde). Además está descompensado, probablemente por una infección.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 114 2.01.1.074 · Hiperplasia suprarrenal co

Un niño de 7 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 46 g/dl, sodio: 130 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

A) Niveles plasmáticos de cortisol basal
B) Insulinemia basal
C) Creatinina plasmática
D) Amilasemia
E) Cetonemia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es una insuficiencia suprarrenal (hiperplasia suprarrenal congénita o HSRC es lo más frecuente en pediatría), por la acidosis metabólica, hipoglicemia, tendencia al compromiso hemodinámico, hiperkalemia e hiponatremia. La mera sospecha obliga a dar corticoides EV. De las opciones, medir el cortisol es lo más correcto, aunque en niños es fundamental, además, medir la 17-OH-progesterona, por ser el marcador específico de la HSRC.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 70 2.01.1.074 · Hiperplasia suprarrenal co

Un recién nacido de 28 semanas, comienza con decaimiento y vómitos, desde hace una semana, con tendencia a la deshidratación. Al examen físico, está hipotenso, taquicárdico, con genitales masculinos, sin otros hallazgos. Sus electrolitos muestran Na+: 129 mEq/l, K+: 6,5 mEq/L, Cl: 89 mEq/L. Además, de la solución fisiológica, ¿qué medicamento se debe administrar en el manejo inicial de este paciente?

A) Ondasentrón
B) Omeprazol
C) Calcio
D) Cefotaximo
E) Hidrocortisona

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una crisis suprarrenal, por hiperplasia suprarrenal congénita (por ser niño). Sugieren esto la clínica, la hipoNa+ y a hiperK+. Se trata con corticoides ev ante la sola sospecha.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 58 2.01.1.074 · Hiperplasia suprarrenal co

Un niño de 8 años ingresa por un cuadro de decaimiento y malestar general, con diarrea y vómitos. Está somnoliento y con compromiso hemodinámico, con FC: 120x' y PA: 70/30 mmHg. Se administran dos bolos de suero fisiológico de 20 cc/kg de peso, sin lograr estabilizarlo. En sus exámenes destaca glicemia 62 mg/dl y pH: 7,29, con exceso de base: -16. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Administrar hidrocortisona endovenosa 2mg/kg de peso
B) Administrar un tercer bolo de suero fisiológico 20 cc/Kg de peso
C) Administrar solución glucosalina 1.700 cc/m2 de superficie corporal
D) Administrar plasma fresco 20 cc/kg de peso
E) Administrar bicarbonato de sodio 2 mEq/Kg de peso

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es una insuficiencia suprarrenal (hiperplasia suprarrenal congénita es lo más frecuente en pediatría), por la acidosis metabólica, con tendencia a la hipoglicemia y shock refractario. La mera sospecha obliga a dar corticoides EV.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 160 2.01.1.074 · Hiperplasia suprarrenal co

Una niña de 7 años, con antecedente de hiperplasia suprarrenal congénita, en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona, consulta por cuadro de 4 días de diarrea, fiebre y malestar general. Al examen físico tiene leve taquicardia y algunos signos de deshidratación. Además de la reposición de volumen, ¿qué conducta es la más adecuada?

A) Fludrocortisona endovenosa
B) Betametasona oral
C) Prednisona oral
D) Hidrocortisona endovenosa
E) Aumentar la dosis de hidrocortisona oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se sospecha una insuficiencia suprarrenal aguda, por la clínica (deshidratación y taquicardia) y el antecedente de la HSRC (se descompensó por la infección y la diarrea). Ante la sospecha, se deben administrar corticoides de acción rápida, como la hidrocortisona.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 161 2.01.1.074 · Hiperplasia suprarrenal co

Un niño de 14 años consulta por dolor abdominal y vómitos de 3 días de evolución, con tendencia a la deshidratación. Hace dos meses estuvo hospitalizado por un cuadro similar, para hidratación endovenosa. Al examen físico tiene FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, T°: 36,8°C. Se solicitan exámenes, que muestran glicemia: 36 g/dl, sodio: 126 mEq/L, potasio: 5,8 mEq/L, pH: 7,32, bicarbonato: 16 mEq/L. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

A) Niveles plasmáticos de cortisol basal
B) Prueba de tolerancia a la glucosa con curva de insulina
C) Creatinina plasmática
D) Amilasemia
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sospecha es nuevamente una insuficiencia suprarrenal, por la clínica y por la hiperkalemia, hiponatremia e hipoglicemia. Se diagnostica con el test de estimulación con ACTH (cortisol basal y post-ACTH), pero comenzar con el cortisol basal es una respuesta aceptable y la única que podía ser.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 165 2.01.1.043 · Hemorragia digestiva

Un lactante de 9 meses de edad presenta cuadro de irritabilidad y llanto, asociado a un episodio de deposiciones con sangre roja abundante hace 3 horas. Al examen Fsico, está irritable y llora desconsoladamente a la palpación abdominal. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?

A) TAC de abdomen y pelvis
B) Colonoscopía
C) Endoscopía diges2va alta
D) Cin2gra:a con tecnecio 99m
E) Radiogra:a de abdomen simple

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El cuadro clínico sugiere una intususcepción intestinal, cuyo examen de elección es la ecografía abdominal. Sin embargo, no está entre las opciones, por lo que lo más probable es que quien redactó la pregunta quería preguntar un diverVculo de Meckel complicado. El diverVculo de Meckel se estudia con cintigrafía con tecnecio 99m, también llamada “cintigrafía de Meckel”.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 11 2.01.1.043 · Hemorragia digestiva

Un paciente de 6 años, sin antecedentes, es traído por presentar sangrado rectal fresco en gotas al final de las deposiciones, no asociado a dolor, ni otros síntomas. Al examen físico se encuentra con índice de masa corporal adecuado para su edad, abdomen blando, depresible y no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Úlcera rectal solitaria
B) Hemorroides
C) Divertículo de Meckel
D) Pólipos juvenil
E) Fisura anal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un escolar con hematoquezia intermitente, no grave, sin más síntomas. Sospechar pólipo juvenil, que es una causa frecuente de HDB en esa edad. Son hamartomas vasculares.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 153 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un lactante de 3 meses presenta aparición de lesiones en el abdomen y muslo, que se muestran a continuación: Foto 16 (https://accesspediatrics.mhmedical.com/content.aspx?bookid=447&sectionid=40442582). ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus herpes simplex
B) Streptococcus pyogenes
C) Virus varicela zóster
D) Virus pox
E) Staphilococcus aureus

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Staphilococcus aureus). Es un impétigo buloso, causado por S. aureus.. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 26 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un niño de 3 años presenta lesiones pruriginosas en la nariz y la cara de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecia lo siguiente: ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Curaciones con suero fisiológico
B) Curaciones con povidona yodada
C) Aciclovir oral por 5 días
D) Prednisona oral por 7 días
E) Flucloxacilina por 7 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un impétigo clásico. Se trata con cloxacilina, flucloxacilina, cefadroxilo o amoxi-clavulánico por 7 a 10 días. O bien con mupirocina o furazolidona tópica.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 90 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un paciente de 8 años presenta aparición de lesiones en la cara, desde hace 3 días, las que han aumentado. Al examen físico se aprecia lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

A) Acné
B) Rosácea
C) Erisipela
D) Impétigo
E) Antrax

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Impétigo** (opción **D**). Se ve en la foto: Las costras melicéricas.. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 28 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Niño con lesiones costrosas amarillentas periorifaciales. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Streptococcus pyogenes
B) Herpes simplex virus
C) Candida albicans
D) Staphylococcus aureus
E) Molluscum contagiosum

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Staphylococcus aureus). Staphylococcus aureus. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 29 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un niño de 7 años presenta lesiones pruriginosas en la nariz y la cara de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecia lo siguiente (fuente: paperblog): ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Curaciones con suero fisiológico
B) Curaciones con povidona yodada
C) Aciclovir oral por 5 días
D) Prednisona oral por 7 días
E) Flucloxacilina oral por 7 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una varicela, cuyo tratamiento es sintomático (paracetamol si fiebre: ya no tiene; y antiH1 si prurito). El aciclovir o valaciclovir se indica en mayores de 13 años, en el segundo caso intradomiciliario, en casos graves y en inmunodeprimidos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 43 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un niño de 10 años presenta, desde hace algunas semanas, una lesión en la cara lateral del índice derecho, dolorosa. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, hiperqueratósica, con puntos negros en su superficie, la que se muestra en la siguiente imagen: Fuente: https://www.dermrounds.com/ ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Molusco contagioso
B) Melanoma
C) Panadizo
D) Verruga vulgar
E) Cuerpo extraño periungueal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Verruga vulgar** (opción **D**). Es una verruga paraungueal clásica.. El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 13 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un paciente de 8 años, sin antecedentes, es traído por presentar múltiples pápulas de 3-4 milímetros de diámetro en manos, tórax y extremidades, algunas de ellas agrupadas en forma lineal, asociado a prurito ocasional. El diagnóstico más probable

A) Molusco contagioso
B) Fibromatosis
C) Liquen plano
D) Verrugas planas
E) Dermatitis atópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es la única respuesta posible, ya que las verrugas planas pueden tener fenómeno de Koebner (aparecen lesiones lineales en zona de traumatismo) y se suelen ubicar en las manos y extremidades. El liquen plano no afecta el tórax y suele ser en edades mayores (sí puede tener Koebner). Pregunta rara, ya que falta lo más importante de las verrugas planas, que es la pérdida del dibujo cutáneo.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 60 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un niño de 3 meses de edad, presenta lesiones cutáneas en la zona del pañal, desde hace 2 días, las que se muestran a continuación (fuente: https://smaciac.wordpress.com/2014): ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus herpes simplex
B) Virus herpes zóster
C) Streptococcus pyogenes
D) Candida albicans
E) Staphilococcus aureus

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Virus herpes zóster). El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 152 2.01.1.011 · Infecciones de piel y part

Un recién nacido que, después de la caída del cordón umbilical, presenta aumento de volumen, de color rosado, bordes netos y superficie brillante, en la zona umbilical. El tratamiento más adecuado es:

A) Nitrato de plata
B) Povidona yodada
C) Quirúrgico
D) Neomicina más mupirocina
E) Furazolidona

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un granuloma umbilical. En general se observa (por lo que el NiTrato de tocarlo es mejor que el nitrato de plata), pero de las opciones era la mejor.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 151 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 2 meses, con antecedente de haber nacido a las 34 semanas de gestación, acude a control. ¿En qué momento debe administrarse la vacuna antineumocócica conjugada?

A) En este momento
B) En 4 semanas más
C) En 6 semanas más
D) A los 12 meses de edad
E) No debe administrarse

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El calendario de vacunas se administra según la edad cronológica y no según la edad ajustada (en los prematuros se ajusta su edad para efectos del crecimiento y desarrollo). La única vacuna que sí se debe ajustar es la BCG, que se administrar al alcanzar un peso mínimo de 2 kilogramos y no antes.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 67 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 9 meses debe vacunarse por primera vez contra la influenza. Tiene antecedente de haber desarrollado un rash eritematoso en las dos oportunidades en las que se le dio a probar el huevo. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su vacunación?

A) Vacunar, de acuerdo al programa, sin cambios
B) Prohibir permanentemente la vacunación contra la influenza
C) Esperar la reacción ante la vacuna trivírica y decidir según aquello
D) Postergar la vacunación hasta que cumpla 24 meses
E) Realizar test cutáneo de alergia y decidir según resultado

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna. Solo son contraindicaciones las reacciones adversas severas, con las dosis previas o la alergia grave y conocida a alguno de sus componentes.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 103 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 12 meses recibe sus vacunas, según el Plan Nacional de Inmunizacio- nes, más una dosis de la vacuna pentavalente, que estaba atrasada. Diez días después, presenta fibre hasta 38 grados Celsius. ¿Qué vacuna es la responsable de la fiebre, con mayor probabilidad?

A) Antimeningocócica
B) Antineumocócica
C) Trivírica
D) Pertusis
E) Anti-Haemophilus

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La pertusis da fiebre de inmediato, o al día siguiente. La trivírica, por ser a micro- organismo vivo, puede producir un cuadro febril 7 a 10 días después.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 164 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 2 meses, con antecedente de haber nacido a las 34 semanas de gestación, acude a control. ¿En qué momento debe administrarse la vacuna antineumocócica conjugada?

A) En este momento
B) En 4 semanas más
C) En 6 semanas más
D) A los 4 meses de edad
E) No debe administrarse

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vacuna antineumocócica se administra a los 2, 4 y 12 meses. No se ajusta por edad gestacional. Además, el ajuste solo se hace en menores de 32 semanas (y aunque así fuera, esta vacuna no se ajusta).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 123 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 2 meses, es traído por su madre a vacunarse. ¿Qué vacuna, fuera de las del Plan Nacional de Inmunizaciones, se le puede recomendar?

A) Rotavirus
B) Varicela
C) Pneumocócica polisacárida
D) Hepatitis A
E) Trivírica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La varicela y hepatitis A sí se recomiendan, pero al año de edad. La neumocócica polisacárida, no sirve en niños menores de 2 años (por eso se da la conjugada).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 131 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un lactante de 18 meses, con antecedente de haber nacido prematuro, está en tratamiento con cor8coides sistémicos debido a un cuadro de síndrome bronquial obstruc8vo recurrente severo. Su úl8ma vacunación fue con vacuna BCG, la que recibió poco 8empo después de nacer, por lo que su madre consulta para regularizar su calendario de vacunas. ¿Qué vacuna está contraindicada mientras permanezca u8lizando cor8coides?

A) An2neumocócica
B) An2meningocócica
C) Tres vírica
D) Virus hepa22s A
E) Hexavalente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Están contraindicadas las vacunas a microorganismo vivo (tresvírica, varicela, fiebre amarilla, rotavirus oral). Sobre el esquema para ponerse al día en su calendario, se resume en “se ponen todas las vacunas pendientes juntas, esperando un mes para los refuerzos”. Por tanto, le corresponden las de los 2 meses, 12 meses y 18 meses (antineumocócica, hexavalente, antimeningocócica, hepaGGs A, con contraindicación de la tresvírica y antivaricela. Vale la pena mencionar que en la práctica, en muchos centros de vacunación administran hasta un máximo de 4 inyecciones, debiendo retrasar un mes la administración de las otras, si es que son muchas dosis las que debe recibir.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 150 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un lactante de 12 meses ha presentado un exantema eritematoso generalizado, en las dos ocasiones en que se ha introducido huevo a su dieta. No tiene otros antecedentes. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

A) Administrarla en este momento
B) Eliminarla de su esquema de vacunación
C) Administrarla a los 18 meses
D) Esperar a los 4 años para administrarla
E) Esperar a que esté en primero básico para administrarla

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vacuna trivírica se administra a los 12 meses y luego se refuerza en primera básico (6 años, aunque desde el 2022 se cambió el refuerzo a los 3 años, junto con el de la varicela, cuya primera dosis es a los 18 meses). La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna actualmente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 71 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño recibe sus vacunas a los 2 meses. Algunas horas después evoluciona con decaimiento, hiporreactividad, hipotonía, fiebre de 37,7°C, seguido de convulsiones generalizadas, autolimitadas, con palidez y llene capilar menor a 1 segundo. El cuadro dura dos horas y luego se recupera por completo. ¿Qué componente de la vacuna es causante de esta reacción, con mayor probabilidad?

A) Toxoide tetánico
B) Toxoide diftérico
C) VPO
D) VHIB
E) Pertusis celular

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vacuna pertusis celular ya no se usa en Chile, precisamente porque tenía efectos adversos muy graves, como los ahí descritos.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 67 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

A) VPO
B) VPI
C) Rotavirus oral
D) Toxoide tetánico
E) Toxoide diftérico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La opción correcta es la **C** (Rotavirus oral). En este escenario clínico, rotavirus oral se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 68 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un lactante de 12 meses ha comido huevo en dos oportunidades y en ambas ha presentado un exantema eritematoso generalizado, sin otras manifestaciones. ¿Qué conducta es la más adecuada, respecto a la vacuna trivírica?

A) Administrarla en este momento
B) Eliminarla de su esquema de vacunación
C) Administrarla a los 18 meses
D) Esperar a los 4 años para administrarla
E) Esperar a que esté en primero básico para administrarla

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Administrarla en este momento** (opción **A**). La alergia al huevo no contraindica ninguna vacuna.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 87 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un lactante de 12 meses de edad, que a los 9 meses presentó un exantema, al introducir huevo a su alimentación por lo que fue suspendido, sin haberlo comido de nuevo. ¿Cuál es la conducta a tomar con repecho a la vacuna trivírica?

A) Aplicar a los 12 meses
B) Contraindicar la vacuna
C) Aplicar a los 18 meses
D) Diferir hasta los 2 años
E) Realizar IgE específica del huevo y decidir según resultado

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alergia al huevo actualmente no es contraindicación de la vacuna trivírica, a menos que haya requerido hospitalización, caso en el que igualmente se da la vacuna, pero en el hospital, bajo observación.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 15 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un lactante de 2 meses de edad, sin antecedentes perinatales, acude a control donde se le administran sus vacunas según el programa nacional de inmunizaciones, doce horas después presenta convulsión tonicoclónica generalizada que dura tres minutos evolucionando posteriormente en buenas condiciones. A futuro la conducta más adecuada con este paciente es:

A) No volver a vacunar.
B) Vacunar con DPT al año de vida
C) Continuar calendario de vacunación de forma normal
D) Indicar paracetamol durante la próxima vacunación
E) Reemplazar DPT con DPT acelular.

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Fue una reacción a la Pertusis celular. Se debe cambiar por acelular. Hoy se usa la pentavalente y no la DPT, sin embargo es la única respuesta correcta.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 24 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Niño con reacción anafiláctica al huevo hace 1 mes. ¿Qué vacuna está contraindicada?

A) Triple viral (SRP)
B) Influenza inactivada
C) Hepatitis A
D) Varicela
E) Fiebre amarilla

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La opción correcta es la **E** (Fiebre amarilla). En este escenario clínico, fiebre amarilla se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 2 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

¿Qué vacuna está contraindicada en un niño con antecedente de anafilaxia en relación a la ingesta de huevo?

A) Vacuna neumocócica conjugada
B) Vacuna tres vírica
C) Vacuna antimeningocócica
D) Vacuna antirrábica
E) Vacuna contra la fiebre amarilla

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La opción correcta es la **C** (Vacuna antimeningocócica). En este escenario clínico, vacuna antimeningocócica se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 37 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

67) Un lactante de 4 meses acude a su control de niño sano. Tiene antecedente de una invaginación intestinal a los 2 meses, ¿cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en este paciente?

A) VPO
B) VPI
C) Rotavirus oral
D) Toxoide tetánico
E) Toxoide diftérico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La opción correcta es la **C** (Rotavirus oral). En este escenario clínico, rotavirus oral se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 55 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Lactante de 8 meses con inmunodeficiencia combinada severa (SCID) diagnosticada. ¿Cuál de las siguientes vacunas está absolutamente contraindicada?

A) Vacuna antihepatitis B
B) Vacuna polio oral (OPV) de virus vivos atenuados
C) Vacuna antineumocócica conjugada
D) BCG inactivada
E) Vacuna antiinfluenza inactivada

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Vacunas con virus vivos atenuados (OPV, SRP, varicela, BCG) están contraindicadas en inmunodeficiencias graves. La OPV puede causar poliomielitis paralítica por virus vacunal en inmunocomprometidos. Se usa vacuna IPV (inactivada) en su lugar.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 93 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 7 años es mordido por un perro callejero en el brazo derecho. Además del manejo de la herida, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto a la profilaxis de la rabia?

A) Observar al niño por 10 días
B) Vacunar al niño solo si el perro presenta síntomas
C) Administrar la vacuna antirrábica al niño
D) Vacunar al niño solo si el perro muere
E) Administrar inmunoglobulina antirrábica al niño

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La normativa actual dice que se debe vacunar en caso de que la mordedura sea por un animal que no es observable (independiente de si hay o no provocación). También se vacuna en caso de contacto con murciélagos (no necesariamente mordedura) y en mordeduras por animales rabiosos, sintomáticos, que mueren inexplicadamente o que se trata de animales diferentes a las mascotas habituales.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 133 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 9 años estuvo en contacto con un paciente con varicela hace 48 horas. No ha tenido varicela y no está vacunado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Vacuna antivaricela
B) Aciclovir
C) Valaciclovir
D) IgG antivaricela
E) Paracetamol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta demasiado discutible. La IgG antivaricela es la medida más efectiva, pero es muy cara y no está disponible. La guía minsal solo la recomienda en casos seleccionados. Hay estudios que dicen que la vacuna es útil hasta 4 días posteriores a la exposición (es lo que se suele hacer por no haber IgG disponible). Hay estudios que avalan el uso de aciclovir (probablemente también sirva el valaciclovir) para prevenir la varicela grave. Finalmente no es obligatorio dar profilaxis de varicela a pacientes sin factores de riesgo. Pésima pregunta

---

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 101 2.01.3.006 · Inmunizaciones en Chile (P

Un niño de 8 años, inmigrante, que no ha recibido la vacuna BCG. Está asintomático y su examen físico es normal. Su padre está siendo tratado para la tuberculosis en su país de origen. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Solicitar PPD
B) Solicitar radiografía de tórax
C) Solicitar baciloscopías
D) Iniciar profilaxis con isoniazida
E) Administrar la vacuna BCG

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Administrar la vacuna BCG** (opción **E**). Baciloscopías de expectoración: examen de elección; pedir 3-4; sensibilidad 80%; muestra válida si > 50 neutrófilos/campo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 146 2.01.1.116 · Enterocolitis necrotizante

Un recién nacido de 10 días de vida, con antecedente de haber nacido prematuro a las 27 semanas, siendo alimentado con fórmula láctea para prematuros por sonda nasogástrica, presenta un cuadro de dos días de evolución de distensión abdominal y aumento de la retención láctea obje8vada por la sonda. Se solicita radiograFa simple de abdomen, que muestra dilatación de asas intes8nales, con zonas de engrosamiento de la pared intes8nal y visualización de burbujas en algunos segmentos. Además de suspender la fórmula láctea y asegurar una adecuada hidratación por vía endovenosa, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar resolución quirúrgica inmediata
B) Iniciar alimentación con fórmula hidrolizada de proteínas por sonda nasoenteral
C) Administrar an2bió2cos de amplio espectro por vía endovenosa
D) Realizar endoscopía diges2va alta
E) Alimentar con suero glucosado por vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una enterocoliGs necroGzante, confirmada por la radiografía, que muestra neumatosis intestinal. Su tratamiento consiste en régimen cero, descompresión gástrica mediante sonda, hidratación y alimentación parenteral, antibióticos de amplio espectro y analgesia, más manejo de las complicaciones. La cirugía se reserva a los casos complicados (perforación, estenosis) y a los muy graves que no responden al tratamiento médico. El suero oral y la alimentación por sonda enteral están contraindicados.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 120 2.01.1.116 · Enterocolitis necrotizante

RNPT que a los 6 días inicia con vómitos importantes y deposiciones con sangre, abdomen timpánico con RHA disminuidos o ausentes (no recuerdo cual), que se vería en la radiografía:

A) Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente de enterocolitis necrotizante)
B) Aire libre intraperitoneal
C) Pared intestinal engrosada
D) Signo de doble burbuja
E) Derrame pleural

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Asas dilatadas con niveles hidroaéreos (esta era la más sugerente de enterocolitis necrotizante)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 30 2.01.1.116 · Enterocolitis necrotizante

Recién nacido de 35 semanas, de 5 días de vida, con antecedente de depresión neonatal recuperada, inicia cuadro caracterizado por vómitos y distensión abdominal asociado a deposiciones con sangre. Al examen físico se palpa abdomen distendido, con tono aumentado. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Ecografía abdominal
B) Tomografía axial computada de abdomen con contraste
C) Radiografía de abdomen
D) Laparotomía exploradora
E) Colonoscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Radiografía de abdomen** (opción **C**). La ECN se estudia con Rx simple.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 153 2.01.1.133 · Malformaciones congénitas

Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta disnea importante al nacer, con taquipnea marcada, cianosis y desaturación arterial. Presenta ruidos cardiacos desplazados al lado izquierdo, con ruidos intestinales en el lado derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra asas intestinales en el hemitórax derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cirugía de urgencia
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Administrar oxígeno en alta concentración, por mascarilla
D) Administrar prostaglandina
E) Realizar intubación orotraqueal y conectar a ventilador mecánico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una hernia diafragmática. Produce hipoplasia pulmonar. Se debe intubar, conectar al ventilador de alta frecuencia y probablemente a la membrana de oxigenación extracorpórea y la cirugía se postpone, para cuando esté estable, con los pulmones más desarrollados. Eso es pregunta para especialistas, no para médico general.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 74 2.01.1.133 · Malformaciones congénitas

Un recién nacido de término presenta dificultad respiratoria severa y progresiva. Al examen físico se aprecia abdomen excavado y se auscultan ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra niveles hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la secuela más importante de esta patología?

A) Estenosis traqueal
B) Compresión hepática
C) Estenosis intestinal
D) Compresión del ventrículo izquierdo
E) Hipoplasia pulmonar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Hipoplasia pulmonar). La hernia diafragmática congénita se complica con hipoplasia pulmonar que puede ser muy grave.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 19 2.01.1.133 · Malformaciones congénitas

Un recién nacido presenta marcada dificultad respiratoria. Al examen física tiene abolición del murmullo pulmonar izquierdo y se auscultan los ruidos cardíacos desplazados, en el lado derecho. Su abdomen está excavado. La conducta inicial es:

A) Cirugía de urgencia
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Realizar toracostomía de urgencia
D) Administrar prostaglandinas y oxígeno al 100%
E) Ventilación a presión positiva por mascarilla

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una hernia diafragmática congénita, que producen hipoplasia pulmonar. Se trata con VMI de alta frecuencia (para lo que requiere intubar) más cirugía diferida, en algunas semanas (no ahora).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 10 2.01.1.133 · Malformaciones congénitas

Un recién nacido de 26 días de vida, con antecedente de caída del cordón umbilical hace 8 días, presenta aumento de volumen en la zona. Al examen físico se observa salida continua de líquido por el ombligo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hernia umbilical
B) Divertículo de Meckel
C) Granuloma umbilical
D) Onfalitis
E) Persistencia del conducto onfalomesentérico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Persistencia del conducto onfalomesentérico: El cordón umbilical normalmente se cae entre los 7 y 14 días de vida. En este caso, la demora en la caída, junto con la salida continua de líquido por el ombligo, sugiere persistencia del conducto onfalomesentérico (salida de contenido intestinal), o bien una persistencia del uraco (salida de orina). El hipotiroidismo congénito y el ombligo húmedo son causas más comunes de retraso en la caída del cordón, pero sin la salida de líquido.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 31 2.01.1.133 · Malformaciones congénitas

Un lactante de 6 meses, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar epifora desde hace 2 meses, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia córnea de 15mm de diámetro en ojo izquierdo, asociado a opacidad corneal. El diagnóstico más probable es:

A) Retinoblastoma
B) Catarata congénita
C) Atresia del conducto lacrimal
D) Glaucoma congénito
E) Persistencia del vítreo primario hiperplásico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Glaucoma congénito** (opción **D**). De libro: megalocórnea, epifora y opacidad corneal.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 85 2.01.2.003 · Aspiración cuerpo extraño

Una niña de dos años presenta un episodio brusco de tos intensa, asociado a cianosis y disnea, que remite luego de pocos minutos. Persiste luego con tos en salvas y expectoración. Al examen pulmonar se auscultan roncus y sibilancias, mayores en el lado derecho. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar PCR para Bordetella pertusis
B) Solicitar TAC de tórax
C) Solicitar broncoscopía
D) Realizar laringoscopía rígida
E) Iniciar antibióticos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un cuerpo extraño bronquial clásico, probablemente en el bronquio derecho. Si bien el primer examen suele ser la radiografía, el manejo y extracción se realiza con broncoscopía flexible o rígida, según disponibilidad. La TAC no suele aportar mucho más que la radiografía y, sea como sea, la clínica tan categórica obliga a la broncoscopía.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 127 2.01.2.003 · Aspiración cuerpo extraño

Un lactante de 1 año de presenta un ataque súbito de tos, sofocamiento y dificultad respiratoria. Al examen presenta sibilancias y disminución del murmullo pulmonar, con FR: 34x'. El diagnóstico más probable es:

A) Neumotórax
B) Laringitis aguda
C) Bronquitis obstructiva
D) Cuerpo extraño bronquial
E) Angioedema

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es el cuadro clásico de aspiración de cuerpo extraño (síndrome de penetración: tos intensa; y luego clínica obstructiva localizada).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 35 2.01.2.003 · Aspiración cuerpo extraño

Un lactante de 10 meses de edad, sin antecedentes, mientras come su almuerzo comienza súbitamente con tos asociado a disminución del esfuerzo respiratorio e hipotonía. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Iniciar reanimación cardiopulmonar
B) Exploración digital de su cavidad oral
C) Iniciar presión digital en epigastrio
D) Dar golpes en la espalda
E) Iniciar ventilaciones boca a boca

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un cuerpo extraño laríngeo obstructivo en un niño menor de 1 año, por lo que se deben dar 5 golpes en la espalda. Si no funciona, se hacen 5 compresiones en el pecho y luego se repiten los golpes en la espalda y así sucesivamente. Sobre el año se hace Heimlich.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 64 2.01.2.003 · Aspiración cuerpo extraño

Una niña de 3 años presenta tos persistente desde hace 7 días, inicialmente seca, pero que desde hace 3 días se volvió produc8va, por lo que se le indicó amoxicilina oral, sin mayor respuesta. Sus signos vitales muestran temperatura 37,1 °C, frecuencia respiratoria 25 por minuto, saturación de oxígeno 97% y frecuencia cardíaca 95 la8dos por minuto. Al examen Fsico, se escucha estridor respiratorio, y se observa 8raje supraesternal y subcostal. En la auscultación cardíaca 8ene ritmo regular sin soplos y en la auscultación respiratoria se constatan sibilancias en el lado derecho, además de oírse el estridor respiratorio. Se solicita radiograFa de tórax que muestra atelectasia del lóbulo medio. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Laringi2s viral
B) Bronquioli2s aguda
C) Neumonía aapica
D) Cuerpo extraño bronquial
E) Traqueí2s bacteriana

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un cuerpo extraño bronquial clásico, en especial por la localización de las alteraciones (bronquio derecho, con afectación de lóbulo inferior y medio es lo clásico). La conducta en este caso es proceder a la broncoscopía rígida, que es diagnóstica y terapéutica.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 33 2.01.2.019 · Obstrucción intestinal

Usted evalúa a un recién nacido de término, con antecedente de síndrome de Down, quien, desde el segundo día de vida, presenta vómitos abundantes y explosivos, que impiden su adecuada alimentación. Al examen físico se observa irritable, con distensión abdominal, por lo que se solicita radiografía abdominal que muestra imagen de doble burbuja, siendo de mayor tamaño la burbuja del lado izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atresia yeyunal
B) Atresia duodenal
C) Enterocolitis necrotizante
D) Estenosis hipertrófica del píloro
E) Malrotación intestinal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Atresia Duodenal: La imagen de "doble burbuja" y el cuadro clínico apuntan a una atresia duodenal. La enterocolitis necrotizante sí puede tener vómitos, pero se manifestaría con antecedentes de prematurez o asfixia, heces con sangre y neumatosis intestinal en la radiografía. La estenosis hipertrófica del píloro, aunque presenta síntomas similares, suele aparecer más tarde, entre las 2 y 6 semanas de vida.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 125 2.01.2.019 · Obstrucción intestinal

Un recién nacido de 5 días, aún no ha eliminado meconio. Además presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Se realiza un enema baritado, que muestra un ano permeable, con colon proximal dilatado y colon distal estrecho. El examen más adecuado para confirmar el diagnóstico es:

A) TAC abdominal
B) Ecografía abdominal
C) Test del sudor
D) Biopsia por succión
E) Radiografía de abdomen simple

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Era una enfermedad de Hirschsprüng, que se diagnostica con biopsia colorrectal (busca la aganglionosis del plexo nervioso submucoso o mientérico).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 77 2.01.2.019 · Obstrucción intestinal

Una lactante de 8 meses de edad, con antecedente de prematurez, presenta un cuadro de 12 horas de evolución, de irritabilidad, llanto y dolor abdominal, asociado a dos de posiciones sanguinolentas. Al examen físico presenta abdomen blando y doloroso a la palpación. En su analítica destaca hematocrito de 34%, con Hemoglobina de 11,2 g/dl, leucocitos: 14.500 por mm3 y plaquetas: 230.000 por mm3. El diagnóstico más probable es:

A) Enterocolitis necrotizante
B) Divertículo de Meckel complicado
C) Atresia esófagica
D) Invaginacion intestinal
E) Shigellosis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una invaginación o intususcepción clásica (incluyendo la edad y la clínica: dolor y hematoquecia).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 42 2.01.2.019 · Obstrucción intestinal

Un paciente de 2 años de edad, sin antecedentes, con historia de dolor abominal difuso e intenso de inicio brusco, que luego disminuye y se asocia a deposiciones de color rojo oscuro, sin otros síntomas. Actualmente no presenta dolor y su examen físico es normal. El examen de elección en este caso es:

A) Ecografía
B) Tomografía axial computada de abdomen
C) Colonoscopía
D) Cintigrafía
E) Radiografía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Ecografía). Tiene una intususcepción o invaginación intestinal. Se estudia con Eco.. :::note Puede presentarse sin diagnóstico previo de preeclampsia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 159 2.01.1.035 · Síndrome purpúrico

Un niño de 8 años acude al servicio de urgencia por un cuadro de epistaxis, que respondió al tratamiento con taponamiento nasal anterior. Al examen físico tiene petequias generalizas y equimosis, principalmente en las extremidades inferiores. Su hemograma muestra hemoglobina 12 g/dl, hematocrito: 36%, plaquetas: 10.000 por mm3 y glóbulos blancos: 5.600 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Púrpura trombocitopénico inmune
C) Púrpura trombocitpénico trombótico
D) Hemofilia
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Púrpura trombocitopénico inmune** (opción **B**). Tiene un PTI clásico: alteración de hemostasia primaria, con trombocitopenia aislada.. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 146 2.01.1.035 · Síndrome purpúrico

Un niño de edad escolar presenta aparición de petequias y equimosis en el dorso y en las extremidades, con epistaxis y gingivorragia, que comenzaron hace 4 días. Se solicita un hemograma, que demuestra hematocrito de 35%, con hemoglobina de 11,8 g/dl, blancos: 9.000 por mm3, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 18.000 por mm3. Además presenta INR: 1,1 y protrombinemia de 80%. El diagnóstico más probable es:

A) Púrpura de Schönlein Henoch
B) Púrpura trombocitopénico inmune
C) Leucemia aguda
D) Meningococcemia
E) Hemofilia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Púrpura trombocitopénico inmune** (opción **B**). Es un PTI clásico, con el hemograma característico: trombocitopenia asilada.. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 111 2.01.1.035 · Síndrome purpúrico

Un paciente de 6 años, con historia de que hace dos semanas presentó cuadro caracterizado por rinorrea, odinofagia y tos, el cual fue manejado adecuadamente. Actualmente consulta por presencia de sangrado de encías, sin otros síntomas. Al examen físico destaca en buenas condiciones generales, con petequias en tronco y extremidades, resto normal. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina 12 mg/dL, leucocitos 8.000/mm3 y plaquetas 10.000/mm3. El diagnóstico más probable es:

A) Purpura trombocitopénico trombótico
B) Hemofilia A
C) Púrpura de Schonlein Henoch
D) Purpura trombocitopénico inmune
E) Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Purpura trombocitopénico inmune** (opción **D**). PTI de libro. :::warning Púrpura + FIEBRE = URGENCIA → descartar meningococcemia (instalación aguda, grave) o leucemia aguda (fiebre + adenopatías + esplenomegalia + anemia de días a semanas). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 101 2.01.1.035 · Síndrome purpúrico

Un niño de 5 años cursa un cuadro respiratorio alto desde hace 7 días que ha recibido tratamiento con paracetamol e ibuprofeno. Consulta por aparición de múl8ples lesiones cutáneas consistentes en petequias y equimosis en las extremidades y el abdomen, asociadas a epistaxis en algunas oportunidades. Se solicitan exámenes, destacando hemograma con hematocrito: 42%, hemoglobina: 14 g/dL, glóbulos blancos: 9.500/mm³ con 65% linfocitos, 30% neutrófilos y 5% monocitos, plaquetas: 60.000/mm³. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Leucemia linfá2ca aguda
B) Meningococcemia
C) Púrpura trombocitopénica inmune
D) Alteración de la hemostasia secundaria a fármacos
E) Púrpura de Schönlein-Henoch

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una púrpura trombocitopénica inmune (PTI) confirmada con el hemograma, que muestra una trombocitopenia aislada. Por tener más de 20.000 a 30.000 plaquetas y no tener hemorragias, basta con la observación. El hemograma está normal en la disfunción plaqueraia por AINEs y en la púrpura de Schönlein-Henoch.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 47 2.01.1.035 · Síndrome purpúrico

Una paciente de 12 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de hemorragia gingival al lavarse los dientes, asociado a equimosis frente a pequeños traumatimos desde hace 2 semanas. Al examen físico destacan dichas equimosis y petequias generalizadas, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma donde destaca hemoglobina de 12mg/dL, leucocitos de 7.000/mm3 y plaquetas de 4000/ mm3. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Transfusión de plaquetas
B) Esplenectomía
C) Corticoides
D) Inmunoglobulina no específica
E) Administrar crioprecipitado

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un PTI agudo, pero por tener menos de 20.000 plaquetas, hay que indicarle corticoides. En general solo se observa. Si tuviese hemorragias graves (ej: HDA o hemorragia intracraneal), se debería dar IgG ev. Si fuera crónico: siempre corticoides y si fallan: esplenectomía.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 96 2.01.1.008 · Escarlatina

Pregunta 96 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un niño de 6 años, presenta odinofagia intensa, con fiebre y decaimiento. Además, aparece luego un exantema eritematoso, generalizado, que es más marcado en los pliegues inguinales y axilares. Al examen físico, está febril, con temperatura de 38.7°C, faringe eritematosa. Tiene adenopatías cervicales bilaterales, sensibles y la piel se palpa áspera al tacto. ¿Qué tipo de complicación puede desarrollar este paciente?

A) Aneurismas coronarios
B) Meningitis
C) Fasceítis necrotizante
D) Glomerulonefritis
E) Miocarditis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Glomerulonefritis). La escarlatina se complica con GNAPE.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 48 2.01.1.008 · Escarlatina

Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

A) Hemograma
B) IgM para virus Epstein barr
C) Panel viral
D) Cultivo de secreción faríngea
E) Test pack para Streptococo grupo A

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una escarlatina y el diagnóstico es clínico. No hay que pedir ningún examen, por lo que esta pregunta está técnicamente mala. El cultivo faríngeo es el goldstandard, pero demora. La verdad es que no estoy 100% seguro de que esta sea la respuesta correcta, ya que al igual que en el Herpes, el diagnóstico es clínico y el gold standard es el cultivo. Eso sí, el test pack tiene el resultado es inmediato y hay que iniciar antibióticos ahora (de hecho hay que iniciarlos porque ya está hecho el diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico). Lo más razonable es simplificar la pregunta a ¿cuál es el examen para la escarlatina? y responder cultivo. Además, en algunas recomendaciones de expertos se dice que el cultivo se debe pedir siempre, sin embargo, la mayoría de las recomendaciones dicen que el diagnóstico es clínico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 71 2.01.1.008 · Escarlatina

Un niño de 7 años, consulta por fiebre, malestar general y dolor de garganta, a lo que se le agregó un exantema. Al examen físico presenta adenopatías cervicales anteriores sensibles y un rash generalizado, mayor en los pliegues de los codos y axilas. La piel se palpa áspera. ¿Cuál es el agente más probable?

A) Virus de Ebstein Baar
B) Virus sarampión
C) Estreptococo betahemolítico grupo A
D) Virus rubéola
E) Estafilococo aúreo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Estreptococo betahemolítico grupo A). Es una escarlatina clásica por S. pyogenes (EBHGA).. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 58 2.01.1.076 · Talla baja

Un paciente de 11 años, es traído por sus padres por ser el más bajo de su curso. Ha estado creciendo en el percentil 2 para su edad desde hace años según su curva de crecimiento y al examen físico se aprecia desarrollo puberal Tanner 1, con testículos de 2cc. Sus padres tienen estatura promedio para la población. Se solicita radiografía de carpo que muestra edad ósea de 8 años y 6 meses. El diagnóstico más probable es:

A) Talla baja familiar
B) Hipogonadismo
C) Acondroplasia
D) Enanismo
E) Retardo constitucional del crecimiento

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un retraso constitucional del crecimiento. Edad ósea 2 años menor a la cronológica. Llama la atención los testículos pequeños (aún no inicia la pubertad, pero eso es acorde a su edad biológica = ósea), sin embargo el Klinefelter, no tiene talla baja. El Turner, de las niñas, sí tiene talla baja.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 15 2.01.1.076 · Talla baja

Niña de 8 años consulta por talla baja, tiene percentil de crecimiento 4, con velocidad de crecimiento normal, y edad ósea de 7 años 10 meses, madre mide 1.52 y padre 1.65: cual es la conducta a seguir

A) Controlar en 6 meses
B) Pedir GH
C) Pedir TSH y T4 (no era talla baja, es <p3)
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Controlar en 6 meses** (opción **A**). Algoritmo de Manejo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Pedir GH, Pedir TSH y T4 (no era talla baja, es <p3)) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 14 2.01.1.076 · Talla baja

Una niña de 8 años es traída por su madre, por talla baja. Está creciendo en el percentil 5 para la edad, con velocidad de crecimiento normal. Su madre mide 158 cm y su padre mide 166 cm. Su edad ósea corresponde a 7 años y 10 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar en 6 meses
B) Frenar la pubertad
C) Solicitar un cariograma
D) Solicitar radiografías de huesos largos
E) Solicitar niveles plasmáticos de hormona de crecimiento

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ni siquiera tiene talla baja (talla < 2 DS para la edad), ya que ello equivale a <p3. De todos modos, la historia de padres bajos y la edad ósea acorde a la cronológica, mostraban que se quería preguntar una talla baja familiar.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 80 2.01.1.076 · Talla baja

Un niño de 12 años, con antecedente de un meduloblastoma de fosa posterior, tratado con quimioterapia y radioterapia cerebral, en remisión completa, desde hace 5 años; consulta por talla baja. Su curva de crecimiento demuestra que ha estado creciendo en una talla equivalente al percentil 2 para la edad y, en su examen físico, presenta desarrollo genital en Tanner 3, con vello púbico en Tanner 4. La talla parental estimada es de 170 cm. ¿Cuál es la causa más probable de su talla baja?

A) Retraso pubertad
B) Recidiva tumoral
C) Hipogonadismo
D) Déficit de hormona de crecimiento
E) Talla baja familiar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una talla baja (menor a percentil 3 o -2DS). Tiene desarrollo puberal, así que no es ni retraso puberal ni hipogonadismo. Su talla parental (promedio de talla de madre y padre, ajustada por sexo: se suma 6,5 cm al promedio si el niño tiene sexo masculino y se resta 6,5 cm si tiene sexo femenino) es alta, así que no es TBF. El antecedente de la RT hace que probablemente tenga daño hipofisiario con el déficit de GH, también llamado enanismo.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 63 2.01.1.076 · Talla baja

Una niña 14 años consulta por talla baja. Tiene IMC/edad: p65, Talla/edad: - 2 DS, cabello de implantación baja, cuello alado, mamas y vello púbico en Tanner 1. Trae radiografía de mano, con edad ósea de 11 años. ¿Con que examen debe continuar el estudio?

A) Hemograma
B) Cariotipo
C) Anticuerpos antitransglutaminasa
D) LDH
E) Hormona de crecimiento

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es un síndrome de Turner (talla baja, cuello alado: pterigium coli y retraso puberal). Su edad ósea es menor, por el retraso puberal. Se estudia con cariograma (45 XO).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 62 2.01.1.050 · Cardiopatías congénitas fr

Un recién nacido de término, presenta cianosis desde su nacimiento, con saturación arterial de 65% con aporte de oxígeno al 100%. Al examen físico destaca murmullo pulmonar disminuido en ambos campos pulmonares, soplo sistólico y pulsos presentes. Como parte de su estudio se solicita radiografía de tórax que muestra cargiomegalia y mediastino delgado. El diagnóstico más probable es:

A) Trasposición de grandes vasos
B) Comunicación interauricular
C) Coartación aórtica
D) Canal auriculoventricular
E) Comunicación interventricular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien suele no tener soplos, la TGV es la única opción que muestra una cardiopatía cianótica. Además sí tiene el mediastino delgado.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 162 2.01.1.050 · Cardiopatías congénitas fr

Una niña de 7 meses, con antecedente de síndrome de Down, ha tenido un mal incremento ponderal y aún no duplica su peso de nacimiento. Se cansa al alimentarse y ha presentado varias infecciones respiratorias. Al examen físico se palpa frémito en el precordio izquierdo y se ausculta un soplo holosistólico, ubicado en el mesocardio, con segundo ruido desdoblado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Coartación aórtica
B) Comunicación interauricular
C) Canal auriculoventricular completo
D) Comunicación interventricular
E) Ductus arterioso persistente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por el antecedente del Sd. de Down como por la clínica que mezcla una CIV (soplo holosistólico), con una CIA (2º ruido desdoblado), se trata de un CAV clásico.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 33 2.01.1.050 · Cardiopatías congénitas fr

Niño con mal incremento pondoestatural, se cansa al alimentarse y presenta soplo holosistólico III en mesocardio. ¿Diagnóstico más probable?

A) Estenosis pulmonar
B) Comunicación interauricular
C) Tetralogía de Fallot
D) Comunicación interventricular
E) Coartación de aorta

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Comunicación interventricular** (opción **D**). Comunicación interventricular. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 111 2.01.1.050 · Cardiopatías congénitas fr

Usted controla a una niña de 7 meses de edad, con antecedente de síndrome de Down, con infecciones respiratorias en múltiples ocasiones que han requerido hospita- lización y que aún no ha podido duplicar el peso de nacimiento. Al examen físico se ausculta ritmo regular en dos tonos, con soplo holosistólico intenso, irradiado a dorso, asociado a un desdoblamiento del segundo ruido. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación interauricular tipo ostium secundum
B) Canal auriculoventricular
C) Atresia tricuspidea
D) Ductus arterioso persistente
E) Comunicación interventricular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Canal auriculoventricular** (opción **B**). Es un CAV clásico.. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 138 2.01.1.050 · Cardiopatías congénitas fr

Un recién nacido presenta un soplo pansistólico, que se escucha entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Además presenta algunas crepitaciones escasas en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Comunicación interventricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Estenosis mitral
E) Atresia tricuspidea

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Comunicación interventricular** (opción **B**). Es una CIV clásica. Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 89 2.01.1.050 · Cardiopatías congénitas fr

Un niño de 8 años acude a consulta por dificultad para seguir el ritmo en actividades físicas en la escuela. No tiene antecedentes médicos relevantes, salvo infecciones respiratorias recurrentes en los últimos años. Sus signos vitales son normales, al igual que su auscultación pulmonar. A la auscultación cardiaca, se detecta un soplo continuo de intensidad III/VI en la región paraesternal e infraclavicular izquierda. El niño presenta una talla de -1 desviaciones estándar para su edad y un peso adecuado para su talla. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miocardiopatía hipertrófica
B) Comunicación interventricular
C) Comunicación interauricular
D) Ductus arterioso persistente
E) Soplo funcional

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Ductus Arterioso Persistente: El soplo continuo es característico del ductus arterioso persistente. Se recomienda revisar el resumen de semiología cardíaca.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 39 2.01.1.050 · Cardiopatías congénitas fr

Un recién nacido presenta, a los pocos minutos de nacer, cianosis generalizada, con saturación de 65%. En su examen físico, se ausculta un soplo sistólico eyectivo II/VI paraesternal. Su radiografía de tórax muestra campos pulmonares sin alteraciones, hilios de tamaño normal, recesos costodiafragmáticos libres y mediastino delgado ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Canal auriculoventricular completo
B) Coartación aórtica
C) Comunicación interventricular grande
D) Transposición de grandes arterias
E) Cardiopatía hipertrófica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Revisar el resumen de semiología cardíaca. Si bien la TGV no suele tener soplos, sí puede tenerlo, ya que la arteria pulmonar queda algo estrecha para la sangre que proviene del ventrículo izquierdo y eso produce flujo turbulento. Además, la TGV es la única cardiopatía cianótica de las alternativas y, por ello, es la respuesta correcta con certeza. La TGV sí se caracteriza por un mediastino delgado.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 147 2.01.1.027 · Resfrío común

Un niño de 3 años presenta un cuadro de congestión nasal, con rinorrea serosa, asociada a tos y ligera odinofagia. Al examen físico tiene temperatura 37,3 grados celsius, faringe congestiva, rosada y nariz con rinorrea abundante. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Solución salina intranasal
B) Amoxicilina oral
C) Corticoides nasales
D) Diclofenaco oral
E) Azitromicina oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un resfrío común. No aparecía paracetamol SOS, así que la respuesta más adecuada es el SF intranasal.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 166 2.01.1.027 · Resfrío común

Un paciente de 10 años, es traído por cuadro de 2 días de odinofagia, asociado a tos seca y rinorrea, que durante el primer día se asoció a sensación febril. Al examen físico se encuentra con temperatura de 36,8ºC, faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de tamaño con escaso exudado blanquecino, examen cardiopulmonar normal. El diagnóstico más probable es:

A) Amigdalitis pultácea
B) Influenza
C) Rinofaringitis aguda
D) Coqueluche
E) Adenovirus

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una infección respiratoria alta, con signos virales: tos, rinorrea. Si bien tiene exudado (orienta a adenovirus), no hay mayores indicios que sea por adenovirus (si hubiese conjuntivitis viral sí sería adenovirus). Es seguro que hay una rinofaringitis viral

---

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 130 2.01.1.027 · Resfrío común

Un niño de 4 años presenta fiebre hasta 39 grados Celsius, mialgias y tos de 3 días de evolución. Además ha presentado rinorrea y cefalea. Al examen físico presenta tem- peratura de 38,8 grados y su examen pulmonar es normal. Se realiza test pack para vi- rus respiratorios, que resulta positivo para virus influenza B. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de este paciente?

A) Oseltamivir
B) Acetaminofeno
C) Aciclovir
D) Amantadina
E) Amoxicilina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El tratamiento de elección de la influenza es sintomático. La amantadina no sirve en los tipos B y el oseltamivir casi no sirve después de 48 horas.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 74 2.01.1.027 · Resfrío común

Un paciente de 9 años, es traído por presentar cuadro de 2 días de compromiso del estado general, mialgias, artralgias, tos y fiebre, que durante las últimas horas se agregó cefalea. Al examen físico se encuentra decaído, frecuencia cardiaca de 100 por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, examen pulmonar normal. El agente etiológico más probable es:

A) Adenovirus
B) Streptococo pneumoniae
C) Mycoplasma
D) Virus influenza A
E) Virus respiratorio sincicial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Virus influenza A). Tiene el cuadro de cefalea, tos, fiebre y mialgias.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 159 2.01.1.036 · Trastornos coagulación

Un niño de 2 años presenta tendencia a las hemorragias, ya que sangra con facilidad y presenta múltiples equimosis. En el examen físico, se observan extremidades inferiores con equimosis en distinto grado de resolución, algunas de gran tamaño. Se solicitan exámenes, entre los que destacan hemograma con recuento de plaquetas normal, TP normal y TTPA alargado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Púrpura trombocitopénica inmune
B) Hemofilia
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Enfermedad de Glanzmann
E) Púrpura trombocitopénica trombótica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El alargamiento del TTPA sugiere fuertemente hemofilia. Que tenga una clínica tan florida, en un niño (sexo masculino) pequeño, la sugiere también. Suele evolucionar a hemartrosis y hematomas musculares y de otras partes del cuerpo. PTI y PTT tienen plaquetopenia. EvW y Glanzmann tienen alteración de la hemostasia primaria, con petequias y clínicas generalmente más leves que la hemofilia, aunque sí pueden tener una clínica similar, en las formas más graves. Eso sí, el TTPA suele estar normal, salvo en algunas variantes de la EvW en que sí se puede alargar.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 35 2.01.1.036 · Trastornos coagulación

Niño con equimosis frecuentes, TTPA prolongado al triple, hermano fallecido por hemorragia intracraneal. ¿Cuál es el examen para el diagnóstico?

A) Tiempo de hemorragia (Duke)
B) Recuento de plaquetas y función plaquetaria
C) Factor de Von Willebrand y cofactor de ristocetina
D) Proteínas C y S
E) Factores de coagulación VIII y IX

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Factores de coagulación VIII y IX** (opción **E**). Factores de coagulación VIII y IX. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 23 2.01.1.036 · Trastornos coagulación

Un niño de 8 años presenta epistaxis con frecuencia y, además, tiene antecedente de haber presentado sangramiento bucal prolongado, después de una extracción dental. Al examen físico, se objetivan múltiples equimosis en las piernas y rodillas. Como antecedente, su madre refiere que ella presenta reglas abundantes y también cierta tendencia a tener equimosis. Se solicitan exámenes que muestran protrombinemia: 85%, TTPA: 38 segundos, hemograma con hematocrito: 33%, hemoglobina: 11 g/dl, VCM: 88 ft, glóbulos blancos: 8.000 por mm3 y plaquetas: 323.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hemofilia
B) Trombocitopenia inmune
C) Enfermedad de von Willebrand
D) Síndrome antifosfolípidos
E) Niño sano

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Enfermedad de von Willebrand** (opción **C**). La epistaxis o sangrado nasal es una consulta frecuente en urgencias. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 135 2.01.1.036 · Trastornos coagulación

Un recién nacido, presenta un cefalohematoma de gran tamaño, al momento de nacer. Además, presenta hematoma del sitio de punción de la muestra venosa. Sus padres son asintomáticos, pero uno de sus tíos murió en el periodo neonatal por hemorragia intracraneal. Entre sus exámenes, destaca TP: 70%, TTPA: 65 segundos, hemograma con hematocrito 50%, blancos: 8.400 por mm3 y plaquetas: 350.000 por mm3. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Agregometría plaquetaria
B) Factores de coagulación VIII y IX
C) Estudio de trombofilia
D) Biopsia de médula ósea
E) Frotis de sangre periférica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Factores de coagulación VIII y IX). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Agregometría plaquetaria, Estudio de trombofilia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 77 2.01.1.036 · Trastornos coagulación

Escolar de 8 años, es traído por su madre ya que desde hace años presenta equimosis frente a pequeños traumatismos y en una ocasión presentó un hematoma en muslo al jugar en el colegio. Actualmente presenta sangramiento gingival, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia dicho sangramiento, asociado a equimosis en extremidades. Se solicitan exámenes que muestran hemoglobina 12mg/dL, leucocitos 6.000/mm3, plaquetas 230.000/mm3, tiempo de protrombina normal y tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Enfermedad de Von Willebrand
B) Enfermedad de Bernard Soulier
C) Enfermedad de Glanzmann
D) Hemofilia
E) Escorbuto

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Esta pregunta está muy difícil, ya que la gingivorragia puede estar en la EvW y es más frecuente en ella que en la hemofilia. Además la EvW puede alargar levemente el TTPA. Por ser niño, por tener un hematoma profundo y por tener el TTPA largo, podría ser hemofilia. Sin embargo, que no haya tenido hemartrosis y que solo haya tenido un hematoma muscular, más los otros síntomas, lo más probable es que sea un von Willebrand. Habría que ver bien cómo estaba redactada la pregunta original. Revisar el Eunacom 2015 de julio, que tenía una pregunta similar, pero que era una EvW.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 135 2.01.1.062 · Infección urinaria

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de fiebre hasta 39 grados, asociado a decaimiento e irritabilidad. La madre refiere orinas de mal olor, por lo que se realiza un examen de orina por sondeo, que da salida a un líquido con abundante bacterias, 50 piocitos por campo y escasa hematuria. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Ciprofloxacino
B) Cefadroxilo
C) Nitrofurantoína
D) Gentamicina
E) Cefoperazona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera o segunda generación. Tampoco se usan las quinolonas, por lo mismo.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 29 2.01.1.062 · Infección urinaria

Niño de 8 meses con fiebre, orina por recolector con leucocituria y bacterias abundantes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar antibiótico oral de inmediato
B) Repetir el examen de orina por sondeo vesical
C) Hospitalizar y tratar ITU febril
D) Solicitar ecografía renal y vesical
E) Derivar a nefrología pediátrica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Repetir el examen de orina por sondeo vesical** (opción **B**). Repetir el examen de orina por sondeo vesical. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 83 2.01.1.062 · Infección urinaria

Un niño de 4 años presenta disuria, asociada a molestias abdominales, sin fiebre. Su examen físico no tiene alteraciones. Se solicita sedimento de orina, que muestra 6 a 8 glóbulos blancos por campo y urocultivo, que muestra desarrollo de Escherichia coli multisensible, con 60.000 UFC por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el sedimento y urocultivo
B) Iniciar cefadroxilo 50 mg/Kg/día, por 5 días
C) Iniciar nitrofurantoína 5-7 mg/Kg/día, por 7 días
D) Solicitar cintigrafía DSMA
E) Solicitar ecografía abdominal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En estricto rigor no tiene una ITU, dado que tiene menos de 100.000 colonias en el cultivo de orina obtenida por micción. Dentro de las opciones de manejo están 1. repetirlo y 2. tomar el cultivo por sonda (requiere 10.000 UFC/mm3) o por punción (basta 1 UFC). Una vez que se confirme el diagnóstico recién estaría indicado tratar (B o C sirven) y posteriormente estudiar con la ecografía (toda ITU en pediatría se estudia).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 134 2.01.1.062 · Infección urinaria

Una niña de 5 años consulta por disuria dolorosa, asociado a orinas turbias y de mal olor, sin fiebre. Se solicita un examen de orina por sondeo, que muestra 20 a 30 leucocitos por campo, con 3 a 4 glóbulos rojos por campo y bacterias abundantes. El urocultivo está pendiente. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección?

A) Nitrofurantoína
B) Ciprofloxacino
C) Metronidazol
D) Amoxicilina
E) Cefoperazona

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La ITU baja en pediatría se trata con cefalosporinas de primera generación o con nitrofurantoína. No se usan quinolonas, por su potencial afectación del cartílago de

---

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 156 2.01.1.062 · Infección urinaria

Una niña de 8 meses de edad presenta un cuadro febril hasta 39,2 grados Celsius, sin otros síntomas, ni alteraciones en su examen físico. Se realiza un urocultivo por re- colector, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con 45.000 unidades forma- doras de colonias, por ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tratar con cefadroxilo oral
B) Tratar con nitrofurantoína oral
C) Tratar con amoxicilina oral
D) Solicitar hemograma, VHS y PCR
E) Repetir el urocultivo por sondeo vesical

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El UCT por recolector solo es positivo si es mayor a 100.000 UFC por ml. Así que repetirlo por sondeo es la única opción aceptable.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 117 2.01.1.062 · Infección urinaria

Un niño de 14 meses presenta fiebre hasta 38,6°C desde hace dos días. El examen físico no identifica un foco, por lo que se solicitan exámenes de orina, con muestra obtenida por recolector, que muestra sedimento con 10 glóbulos blancos por campo, 2 a 4 glóbulos rojos por campo, células epiteliales en regular cantidad, bacterias en moderada cantidad y citoquímico con nitritos negativos, ausencia de glucosuria y proteinuria, ausencia de cristales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar cintigrafía renal
B) Solicitar ecografía renal y vesical
C) Solicitar examen de orina por sondeo
D) Iniciar cefadroxilo oral
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar examen de orina por sondeo** (opción **C**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 50 2.01.1.062 · Infección urinaria

Un niño de 3 años, con antecedente de fimosis, presenta fiebre alta, hasta 39,5°C, desde hace 48 horas, asociada a vómitos y malestar general. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca: 130x', T°: 39,0°C, faringe congestiva, examen cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones relevantes. Se solicitan exámenes, entre los que se informa sedimento de orina con 20 glóbulos rojos por campo, 50 glóbulos blancos por campo, bacterias en moderada cantidad; además, tiene hemograma con hematocrito: 42%, hemoglobina: 13 g/dl, leucocitos: 14.000 por mm3 y plaquetas: 228.000 por mm3, con VSG: 42 mm/h. Hemocultivos pendientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Balanopostitis
B) Neumonía adquirida en la comunidad
C) Influenza
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Pielonefritis aguda

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pielonefritis aguda: La fimosis puede orientar a balanopostitis o pielonefritis aguda. La balanopostitis presenta alteraciones cutáneas en el prepucio y glande, sin fiebre. La pielonefritis aguda se presenta con fiebre. En este caso, la leucocituria elevada (50 glóbulos blancos por campo) indica pielonefritis.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 72 2.01.1.062 · Infección urinaria

Lactante de 18 meses, irritable , con sedimento y urocultivo (+), fiebre y decaimiento hace 3 días, antibiograma sensible a imipenem, cipro, Amikacina. ¿qué tratamiento indicar? a. Amikacina b. Carbapenemicos

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Control sano habitual** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 81 2.01.1.062 · Infección urinaria

Una paciente de 6 años, con cuadro caracterizado por disuria, polaquiuria y orinas de mal olor desde hace 2 días, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca temperatura de 36.5ºC, abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación, puño percusión negativa. Se realiza sedimento de orina que muestra 6 eritrocitos y 15 leucocitos por campo, además se solicita urocultivo de segundo chorro en el que hay crecimiento de escherichia coli con 60.000 unidades formadoras de colonia multisensible. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Iniciar Cefadroxilo oral
B) Iniciar Nitrofurantoina oral
C) Solicitar Ecografía renal y vesical
D) Solicitar cintigrafía renal estática
E) Repetir sedimento de orina y urocultivo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Urocultivo está negativo. Idealmente repetirlo por sondeo, porque el sedimento está dudoso y la clínica es sugerente. Pregunta muy rara y difícil. Probablemente venía redactada de una forma distinta en la prueba origina. De las opciones, la más aceptable, dado que el urocultivo es menor a 100 mil colonias, es la repetición.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 49 2.01.1.062 · Infección urinaria

Un niño de 3 años, con antecedente de fimosis, presenta fiebre alta, hasta 39,5°C, desde hace 48 horas, asociada a vómitos y malestar general. Su examen físico muestra frecuencia cardíaca: 130x', T°: 39,0°C, faringe congestiva, examen cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones relevantes. Se solicitan exámenes: sedimento de orina con 20 GR/campo, 50 GB/campo, bacterias en moderada cantidad; hemograma con leucocitos 14.000/mm3, VSG: 42 mm/h. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Balanopostitis
B) Neumonía adquirida en la comunidad
C) Influenza
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Pielonefritis aguda

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pielonefritis aguda: La fimosis puede orientar a balanopostitis o pielonefritis. La balanopostitis presenta alteraciones cutáneas en prepucio y glande, sin fiebre alta. La leucocituria elevada (50 GB/campo) junto con la fiebre indica pielonefritis aguda.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 8 2.01.1.062 · Infección urinaria

Guagua de 2 meses con ITU x atipico (nitritos (-)), fiebre, irritabilidad, con 60 blancos, bacterias abundantes: a. Hospitalizar + ATB amplio espectro. (ITU < 2 meses, ITU Atipica) b. ATB vo y control con UC (la guagua estaba regio, sgy igual podia ser esa), no, menor a 3 es indicación absoluta de hospitalizar (mmm, pero estaba febril, así que la sospecha era PNA) Y estaba “decaído”

A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pneumoniae
C) Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Klebsiella pneumoniae

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Staphylococcus aureus** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 30 2.01.1.062 · Infección urinaria

ITU febril en guagua. ATB con resistencia pero sensible a nitrofurantoína. Cual le dejas (entregaban antibiograma, era E.Coli blee positivo):

A) Carbapenemico (blee se trata con carbapenemicos) b. Amikacina (¿¿pero amika le pegaba bien o no?, SII, salia sensible a AMIKA). Era amika todo el rato. Amika definitivamente c. Las E. Coli BLEE se tratan con carbapenémicos, siempre, independientemente de a qué más sea sensible
B) Control sano habitual
C) Derivar a especialista
D) Hospitalizar
E) Observación domiciliaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Carbapenemico (blee se trata con carbapenemicos) b. Amikacina (¿¿pero amika le pegaba bien o no?, SII, salia sensible a AMIKA). Era amika todo el rato. Amika definitivamente c. Las E. Coli BLEE se tratan con carbapenémicos, siempre, independientemente de a qué más sea sensible). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 162 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Un niño de 8 años, es traído por presentar mal olor axilar desde hace semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia vello púbico escaso y testículos con volumen de 4cc. Su índice de masa corporal está en percentil 50 para su edad y sexo. El diagnóstico más probable es:

A) Pubertad precoz central
B) Pubertad precoz periférica
C) Pubertad temprana
D) Hiperplasia suprarrenal
E) Adrenarquia temprana

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una pubertad precoz (menos de 9 años en varones), con testículos de 4 cc, por lo que están estimulados por las gonadotropinas. Como hay elevación de gonadotropinas, es porque está activado el eje hipotálamo hipófisis, es decir, es central.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 151 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Una niña de 10 meses de edad tiene mamas en desarrollo Tanner II, bilateral. Su crecimiento ha sido adecuado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecografía mamaria
B) Solicitar cariograma
C) Observar y controlar en 2 meses
D) Solicitar niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona
E) Solicitar niveles plasmáticos de 17-OH-progesterona

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La presencia de botón mamario es normal en los recién nacidos y suele durar unas pocas semanas, aunque es posible que persista, incluso hasta los 12 meses. Además, la respuesta suele ser "observar" en cualquier pregunta de pediatría que sea más o menos así: "un niño tiene una cosa rara que no tengo idea, pero todo lo demás está normal".

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 146 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Un niño de 8 años presenta olor axilar. ¿Qué hallazgo debe buscarse para determinar si tiene una pubertad precoz?

A) Ginecomastia
B) Elevación de la 17 hidroxiprogesterona
C) Vello púbico
D) Aumento de la velocidad de crecimiento
E) Aumento de volumen testicular

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Al aumento de volumen testicular es el primer signo de pubertad precoz. Sin embargo también debe evaluarse la presencia de vello púbico, porque es un signo de pubertad precoz igualmente.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 172 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Una niña de 9 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor mamario derecho. Al examen físico presenta mama derecha en Tanner II y mama izquierda en Tanner I, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Realizar ecografía mamaria
B) Controlar en 1 año
C) Solicitar resonancia magnética de silla turca
D) Realizar ecografía pelviana
E) Solicitar 17-OH-progesterona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Controlar en 1 año** (opción **B**). Es una telarquia normal (inicio puberal), que puede ser asimétrica al inicio.. Comparación de las 3 Causas Principales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 62 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Un adolescente de 13 años consulta por aumento de volumen doloroso en relación con la mama derecha. No presenta antecedentes de importancia y sus controles de niño sano han sido normales. Al examen Fsico, se constata aumento de volumen de 3 cm de diámetro retroareolar derecho, sensible a la palpación, y desarrollo puberal genital y pubiano Tanner 3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecogra:a mamaria
B) Solicitar niveles plasmá2cos de prolac2na
C) Controlar en 6 meses
D) Solicitar niveles plasmá2cos de testosterona, FSH y LH
E) Realizar biopsia de la lesión

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una ginecomasGa puberal benigna, la que se observa. Ya Gene desarrollo puberal, lo que es esperable para su edad (pubertad normal en niños comienza entre los 9 y 14 años; en niñas comienza entre los 8 y 13 años). Los signos de alarma en una ginecomasGa son 1. Inicio en adulto o en prepúber (no puberal), 2. Tamaño > 4 cm, 3. Características de cáncer (dura, secreción sanguinolenta, etc.).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 36 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Un niño de 7 años presenta olor axilar, vello púbico en Tanner 2, testículos de 2 cc de volumen. Se solicita radiografía de mano, que muestra edad ósea acorde con la edad cronológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tumor suprarrenal
B) Pubertad precoz central
C) Pubertad precoz periférica
D) Hiperplasia suprarrenal congénita
E) Adrenarquia normal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una adrenarquia normal (olor axilar y en varones puede haber una ligera pu- barquia). Los testículos pequeños hacían imposible una pubertad precoz central y la pubertar precoz periférica es algo muy raro, que habría tenido alteraciones de la edad ósea.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 16 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Niño de 13 años con ginecomastia unilateral y masa 3 cm retroareolar, genitales tanner 3: (repetida años anteriores) a. Observar 1 año

B) Eco mamaria
B) Control sano habitual
C) Derivar a especialista
D) Hospitalizar
E) Observación domiciliaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). :::note El metronidazol en monodosis de 2 g es la elección para tricomoniasis, NO para vaginosis. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 93 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Un adolescente de 13 años, con antecedentes familiares de cáncer de mama, es traído por presentar aumento de volumen en mama derecha, asociado a hipersensibilidad local, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia mama derecha aumentada de volumen y a la palpación, destaca tumoración de consistencia gomosa y fácil de movilizar, desarrollo puberal normal para su edad, sin otros hallazgos. Se solicita ecografía mamaria que muestra nódulo de bordes lisos de 5 milímetros de diámetro. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar estudio genético
B) Tranquilizar a los padres y al paciente, y controlar en un año
C) Indicar tratamiento hormonal y controlar
D) Realizar mastectomía parcial
E) Realizar biopsia estereotáxica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Tranquilizar a los padres y al paciente, y controlar en un año** (opción **B**). Es una ginecomastia puberal benigna. Comparación de las 3 Causas Principales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 100 2.01.1.072 · Alteraciones del desarroll

Un recién nacido de 20 días de vida presenta ginecomastia bilateral. Se palpa tejido mamario de 1,5 cm en cada mama, de consistencia firme. El resto del examen físico es normal y ha subido adecuadamente de peso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar niveles plasmáticos de prolactina
B) Solicitar niveles de estrógenos, progesterona, LH y FSH
C) Solicitar ecografía mamaria
D) Realizar biopsia
E) Observar y controlar ambulatoriamente

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Observar y controlar ambulatoriamente** (opción **E**). Es un hallazgo normal.. Comparación de las 3 Causas Principales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 99 2.01.1.124 · Sepsis neonatal

Recién nacido de 10 días de vida, sin antecedentes perinatales, inicia desde hace 5 horas cuadro caracterizado por fiebre cuantificada hasta 39ºC asociada a rechazo alimentario e hiporreactividad, sin otros síntomas. Su examen físico resulta normal. Se solicita bioquímica de orina que muestra leucocitos ++. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Solicitar sedimento de orina y decidir conducta según resultados
B) Hospitalizar para estudio y manejo
C) Indicar antipiréticos orales y control en dos días
D) Indicar antibióticos vía oral y control en dos días
E) Solicitar ecografía renal y vesical

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Hospitalizar para estudio y manejo** (opción **B**). Es una sepsis neonatal.. Tratamiento: 1° suero fisiológico (reposición de volemia), 2° antibióticos según foco, 3° soporte general. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 129 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre era O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
B) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
C) Ictericia fisiológica
D) Hepatitis neonatal
E) Ictericia por lactancia materna

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una ictericia precoz (menor a 24 horas), indirecta, por lo que lo más probable es que sea hemolítica. Además, por los grupos sanguíneos, solo puede ser por incompatibilidad de grupo clásico (madre O e hijo A o B).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 60 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un recién nacido de 18 horas de vida, desarrolla ictericia hasta los muslos. Se solicitan niveles plasmáticos de bilirrubina que resulta 15,3 mg/dl, con fracción indirecta de 15 mg/dl. La madre es O-IV Rh positiva y el niño es B-I Rh negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo clásico
B) Ictericia hemolítica por incompatibilidad Rh
C) Ictericia fisiológica
D) Hepatitis neonatal
E) Síndrome de Gilbert

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por haber iniciado antes de las primeras 24 horas es patológica. La madre O puede hemolizar al hijo B. La madre Rh positiva no puede hemolizar al hijo Rh negativo (solo hemolizan las madres Rh negativas a los hijos Rh positivos).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 154 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un niño de 6 semanas de vida presenta ictericia desde hace 2 semanas. Al examen físico se aprecia ictérico y presenta deposiciones claras en el pañal, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estenosis hipertrófica del píloro
B) Atresia biliar primaria
C) Hepatitis viral
D) Síndrome de Crigler Najjar
E) Hipotiroidismo congénito

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Atresia biliar primaria** (opción **B**). Es una atresia biliar primaria clásica: ictericia tardía y acolia.. La ictericia neonatal es uno de los temas más frecuentes en el EUNACOM. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 176 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un recién nacido de término presenta ictericia a los 7 días de vida. Se solicita bilirrubina total: 14,2 mg/dl y bilirrubina directa: 4,0 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo al recién nacido
B) Solicitar hemograma, grupo-Rh y prueba de Coombs directo a la madre
C) Solicitar pruebas hepáticas
D) Solicitar sedimento de orina y urocultivo
E) Fototerapia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Parece una ictericia fisiológica, por lo que lo más sensato sería observa evolución. No tiene niveles elevados, como para indicarle fototerapia sobre 20 en RN sanos; sobre 18 en prematuros o con factores de riesgo; sobre 15 en prematuros con factores de riesgo , por lo que la única opción aceptable es estudiarlo, para descartar hemólisis causa de hiperbilirrubinemia indirecta .

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 145 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un niño de 27 días de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 18,8 mg/dl y una bilirrubina directa de 18,0 mg/d. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ictericia por leche materna
B) Ictericia fisiológica
C) Atresia primaria de las vías biliares
D) Hipotiroidismo congénito
E) Hepatitis neonatal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una ictericia tardía y directa, por lo que la atresia biliar primaria es la principal sospecha.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 39 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un lactante de 5 días de vida, alimentado con lactancia materna exclusiva, presenta ictericia en la cara y el tronco, que inició hace 2 días. Se solicta bilirrubina plasmática, que resulta 10 mg/dl, billirrubina directa de 0,3 mg/dl, hematocrito de 56%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hepatitis neonatal
B) Atresia biliar primaria
C) Ictericia fisiológica
D) Ictericia hemolítica
E) Ictericia por leche materna

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Ictericia fisiológica** (opción **C**). No hay nada que oriente a ictericia patológica. Es una ictericia fisiológica clásica.. La ictericia neonatal es uno de los temas más frecuentes en el EUNACOM. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 61 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un niño de 5 semanas de vida presenta ictericia, que inició hace una semana. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y no ha tenido otros síntomas. Se solicitan exámenes que muestran una bilirrubina total de 4,3 mg/dl y una bilirrubina directa de 3,6 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ictericia por lactancia materna
B) Síndrome de Gilbert
C) Atresia primaria de las vías biliares
D) Hipotiroidismo congénito
E) Hepatitis neonatal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una ictericia tardía, de predominio directo, por lo que se sospecha una atresia biliar primaria. A, B y D son de predominio indirecto. La hepatitis neonatal es menos importante como diagnóstico.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 29 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un recién nacido de 2 días de vida, presenta aumento de volumen parietal izquierdo, que deforma la cabeza, limitado a la zona parietal, que no sobrepasa la línea media. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la alteración descrita?

A) Fistulización a la piel
B) Osteomielitis
C) Disección de cuero cabelludo
D) Hiperbilirrubinemia
E) Abscedación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La hiperbilirrubinemia es la complicación más frecuente del cefalohematoma (descrito en el caso). Las demás pueden ocurrir, pero son infrecuentes.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 117 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un lactante de un mes, sin antecedentes perinatales, es traído por presentar ictericia, sin otros síntomas. Al examen físico destaca ictericia que llega hasta los muslos, resto normal. Su desarrollo psicomotor ha sido normal, al igual que su crecimiento y alimentación. Al preguntar dirigidamente, su madre refiere que también ha presentado orinas oscuras. El examen de elección frente a este paciente es:

A) Ecografía abdominal
B) Hormona estimuladora de tiroides
C) Resonancia magnética abdominal
D) Test de coombs
E) Bilirrubinemia diferenciada

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una ictericia tardía. Si bien las orinas oscuras orientan a atresia biliar primaria, lo primero es ver la bili diferenciada. Luego la Eco. La pregunta es difícil.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 154 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un neonato de 21 días de vida, con incremento ponderal deficiente, presenta ictericia que se extiende hasta las piernas. El parto fue por vía vaginal y el embarazo transcurrió sin complicaciones. Su bilirrubina total es de 11,2 mg/dL, con una bilirrubina directa de 7,0 mg/dL. El neonato se encuentra alimentándose con lactancia materna exclusiva y no presenta otros síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atresia de vías biliares
B) Hipotiroidismo congénito
C) Ictericia fisiológica
D) Ictericia por leche materna
E) Síndrome de Gilbert

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Ictericia Neonatal Directa: En un caso de ictericia neonatal tardía de predominio directo, el diagnóstico más probable es atresia de vías biliares. Se debe realizar una ecografía abdominal para confirmar el diagnóstico. Se trata con la cirugía de Kasai.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 6 2.01.1.121 · Ictericia neonatal y del p

Un recién nacido presenta aumento de volumen parietal izquierdo, limitado a la zona parietal, que no sobrepasa la línea media. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la alteración descrita?

A) Fistulización a la piel
B) Osteomielitis
C) Disección de cuero cabelludo
D) Hiperbilirrubinemia
E) Abscedación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los cefalohematomas suelen evolucionar sin complicaciones, aunque pueden com- plicarse con ictericia, por la hemólisis del hematoma.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 70 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 18 meses lleva 3 días con fiebre, cuantificada de 38,8°. Se inicia amoxicilina, desapareciendo la fiebre y apareciendo un exantema eritematoso generalizado, que se muestra en la siguiente imagen: Foto 6 (http://www.childnurture.com/article/XXXXXXX) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Eritema infeccioso
B) Exantema súbito
C) Reacción alérgica a medicamentos
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Síndrome de piel escaldada

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Exantema súbito** (opción **B**). Es un exantema súbito clásico, por virus herpes 6.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 13 2.01.1.009 · Exantemas virales

Lactante de 8 meses con fiebre de 39.5°C durante 5 días. Al sexto día la fiebre cede y aparece exantema rosado generalizado no pruriginoso. El niño está en buen estado general. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Control sano habitual: exantema súbito, evolución benigna
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Iniciar aciclovir
E) Solicitar serología viral urgente

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Exantema súbito (roséola infantil, HHV-6): fiebre alta 3-5 días → cede bruscamente → exantema rosado generalizado. Diagnóstico clínico, evolución benigna y autolimitada. No requiere tratamiento antiviral. Control de rutina.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 52 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un lactante de 14 meses de edad presenta un cuadro febril de 4 días de evolución, con fiebre hasta 39,2°C, la que desaparece abruptamente, dado paso a la aparición de un rash eritematoso maculopapular, que afecta la cara, el tronco y las cuatro extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Eritema infeccioso
B) Síndrome de pie mano boca
C) Síndrome de Kawasaki
D) Exantema súbito
E) Rubéola

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Exantema súbito (Roséola infantil): Es un exantema súbito clásico, que afecta principalmente a niños entre 6 y 12 meses de edad. Se caracteriza por una fiebre muy alta que cesa repentinamente, seguida de la aparición de un rash generalizado.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 35 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 18 meses presenta, desde hace 5 días irritabilidad y fiebre, cuantificada hasta 38,8°. Se inicia amoxicilina, cediendo la fiebre fiebre hace 48 horas y apareciendo un exantema eritematoso generalizado hace 24 horas, que se muestra en la siguiente imagen (fuente: wikipedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Eritema infeccioso
B) Exantema súbito
C) Reacción cutánea a medicamentos
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Rubéola

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Exantema súbito** (opción **B**). Es un exantema súbito clásico. También se llama sexta enfermedad o roséola.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 23 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un lactante de 10 meses de edad presenta eritema en la cara, que al día siguiente se generaliza. Al examen físico tiene un exantema rosado macular tenue, asociado a adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores. El diagnóstico más probable es:

A) Eritema infeccioso
B) Rubéola
C) Exantema por citomegalovirus
D) Sarampión
E) Exantema súbito

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una rubéola clásica. Revisar las clínicas de los exantemas y saberlos de memoria, porque se pregunta segura. Que tenga menos de un año, muestra que no está vacunado.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 37 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 5 años, presenta fiebre baja, hasta 37,5°C y eritema malar. Dos días después se agrega un exantema eritematoso macular en el tronco y extremidades, durando el cuadro un total de 10 días. El agente más probable es:

A) Streptococcus pyogenes
B) Parvovirus B19
C) Virus de Ebstein Baar
D) Virus herpes humano número 6
E) Virus rubéola

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un eritema infeccioso o quinta enfermedad o megaloeritema clásico. Es causado por el PVB19. Cuando tiene ya el eritema (aunque sea el malar) ya no contagia (solo contagia en el pródromo). Revisar las clínicas de los exantemas y saberlos de memoria.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 69 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 5 años, es traído por su madre, por fiebre hasta 38,0°C y aparición de eritema facial marcado, que luego desaparece, dando paso a aparición de un exantema "en encaje", que afecta el abdomen, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, el que ha persistido por 15 días. Ha recibido ibuprofeno para sus síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rubéola
B) Infección por virus Coxsackie A16
C) Infección por parvovirus B19
D) Reacción adversa al ibuprofeno
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Infección por parvovirus B19** (opción **C**). Es un eritema infeccioso clásico. El exantema puede durar hasta 30 días.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 127 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un prescolar de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 38 grados, asociado a eritema en las mejillas, que aumenta en los periodo de fiebre y con el calor y se vuelve más pálido cuando no hay fiebre. Luego se agrega un exantema reticular en el tronco. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus rubéola
B) Virus Coxsackie
C) Parvovirus B19
D) Streptococcus pyogenes
E) Virus herpes 6

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Parvovirus B19). Es un eritema infeccioso, por PVB19 clásico.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 139 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 5 años presenta fiebre no cuantificada, asociada a un exantema que inicia en las mejillas y que luego se extiende a la zona proximal de las extremidades, con una disposición, en encaje. Al examen físico tiene 37,1 grados de temperatura y se aprecia la faringe congestiva, con amígdalas rosadas y el exantema descrito. El diagnóstico más probable es:

A) Exantema súbito
B) Eritema infeccioso
C) Exantema por virus Coxsackie
D) Rubéola
E) Escarlatina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Eritema infeccioso** (opción **B**). Es un eritema unfeccioso clásico, por PVB19.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 27 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un lactante de 10 meses de edad, presenta un cuadro de fiebre hasta 37,8 grados Celsius, asociado a aparición de un exantema generalizado, de timo macular eritematoso, de aspecto tenue. Al examen físico destacan adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, sensibles a la palpación. El diagnóstico más probable es:

A) Exantema súbito
B) Eritema infeccioso
C) Rubeola
D) Sarampión
E) Exantema por citomegalovirus

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una rubeola clásica (exantema macular tenue y generalizado, con adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores). Por tener menos de 1 años, aún no recibe la trivírica.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 132 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 5 años de edad presenta fiebre leve, asociada a eritema malar, que dura 2 días y luego cede. Al cuarto día aparece un exantema que afecta el tronco y las zonas extensoras de las extremidades. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus herpes 6
B) Virus rubeola
C) Virus sarampión
D) Parvovirus B19
E) Streptococcus pyogenes

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy mal intencionada. El VH6 produce exantema súbito, pero habitualmente entre los 6 y 18 meses y con fiebre alta (cercana a 40 grados). El PVB19 produce el eritema infeccioso o quinta enfermedad, que produce el eritema malar (signo de la cachetada) y el exantema con esa distribución. Afecta a escolares con mayor frecuencia.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 168 2.01.1.009 · Exantemas virales

Niño con historia de malestar general y fiebre 37.5°C-37.9°C de una semana de evolución, manejado con ibuprofeno. Le aparecia rash eritematoso en mejillas y Extremidades:

A) Eritema infeccioso
B) RAM
C) KAWASAKI
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Eritema infeccioso). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (RAM, KAWASAKI) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 33 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 5 años presenta un exantema pruriginoso, desde hace 4 días, generalizado y pleomorfo, consistente en máculas, pápulas, vesículas, que inició en el cuero cabelludo y la cara, a lo que luego se extendió al tronco y las extremidades, de proximal a distal. Fue precedido por un cuadro febril. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Aciclovir
B) Valaciclovir
C) Prednisona
D) Clorfenamina maleato
E) Talco mentolado

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Clorfenamina maleato** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Aciclovir, Valaciclovir) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 131 2.01.1.009 · Exantemas virales

Paciente de 3 años de edad, previamente sano, hace dos días inicia cuadro caracterizado por fiebre intensa, cuantificada hasta 39ºC, no asociado a otros síntomas. Su madre le administra acetaminofeno por vía oral durante el primer día, tras lo cual evoluciona con disminución de la fiebre y hoy amanece con exantema maculopapular no pruriginoso, sin fiebre y en buenas condiciones. El agente etiológico más probable es:

A) Citomegalovirus
B) Virus Epstein barr
C) Virus Herpes 6
D) Parvovirus B19
E) Enfermedad de Still

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un exantema súbito clásico, aunque está muy grande para tenerlo (suele ser en menores de dos años)

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 30 2.01.1.009 · Exantemas virales

Niña escolar con fiebre y exantema en mejillas y tronco (aspecto de 'bofetada'). ¿Cuál es el agente más probable?

A) Virus del sarampión
B) Virus de la rubéola
C) Herpes virus 6
D) Enterovirus
E) Parvovirus B19

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Parvovirus B19). Parvovirus B19. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Virus del sarampión, Virus de la rubéola) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 25 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 5 años presenta un exantema pruriginoso, desde hace 4 días, generalizado y pleomorfo, consistente en máculas, pápulas, vesículas, que inició en el cuero cabelludo y luego se extendió al tronco y las extremidades. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Aciclovir
B) Valaciclovir
C) Prednisona
D) Clorfenamina maleato
E) Talco mentolado

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una varicela clásica. Aciclovir y valaciclovir se podrían indicar, pero solo en mayores de 13 años, el segundo caso de la familia, un cuadro grave o un paciente inmunodeprimido. Por tanto, no están indicados, en este caso.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 32 2.01.1.009 · Exantemas virales

Una niña de 4 años es traída por un cuadro de 3 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,5°C y, el día de hoy, aparición de un lesiones cutáneas que abarcan tronco extremidades y cara, como se muestra en la imagen (fuente: dortorgo.es): ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus rubéola
B) Parvovirus B19
C) Coxsackie A16
D) Virus herpes simple
E) Virus herpes 6

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Coxsackie A16). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Virus rubéola, Parvovirus B19) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 31 2.01.1.009 · Exantemas virales

Lactante menor con fiebre alta; cuando cede aparece rash maculopapular en tronco y extremidades. ¿Cuál es el agente más probable?

A) Parvovirus B19
B) Enterovirus
C) Virus herpes 6
D) Adenovirus
E) Virus varicela-zóster

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Virus herpes 6). Virus herpes 6. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Parvovirus B19, Enterovirus) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 43 2.01.1.009 · Exantemas virales

Un niño de 11 meses de edad presenta fiebre hasta 39°C, desde hace 3 días, asociado a irritabilidad, que ha sido manejeada con paracetamol. El día de hoy presenta lesiones cutáneas papulares eritematosas, generalizadas. El resto de su examen físico no tiene alteraciones ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus herpes 6
B) Parvovirus B19
C) Virus Coxsackie A16
D) Virus varicela zóster
E) Virus de Epstein Baar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Virus de Epstein Baar). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Virus herpes 6, Parvovirus B19) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 136 2.01.1.009 · Exantemas virales

Una niña de 7 años presenta aparición de lesiones eritematosas en cara, tronco y extremidades, de 2 días de evolución, que se han asociado a fiebre, malestar general y dolor en ambas manos y tobillos. Al examen Fsico 8ene temperatura 37,1 °C, se observa rinorrea serosa y eritema de ambas mejillas, más lesiones eritematosas re8culares en las extremidades y el abdomen. ¿Cuál es el agente e8ológico más probable?

A) Streptococcus pyogenes
B) Virus herpes 6
C) Parvovirus B19
D) Virus rubéola
E) Virus sarampión

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un eritema infeccioso clásico, también llamado megaloeritema o quinta enfermedad. Su agente es el PVB19.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 138 2.01.2.006 · Deshidratación

Un niño de 6 años, es traído por presentar cuadro de dos días de evolución de diarrea acuosa frecuente, asociado a vómitos, rechazo alimentario y decaimiento. Al examen físico se encuentra somnoliento, frecuencia cardiaca de 110 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg y ojos hundidos. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Indicar suero glucosalino endovenoso en infusión continua
B) Indicar sales de rehidratación oral 200ml luego de cada deposición
C) Indicar sales de rehidratación oral 100 ml por kilogramo a beber en 4 horas y luego reevaluar
D) Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo
E) Indicar alimentación normal, con abundantes líquidos y control en 48 horas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Indicar suero fisiológico 20ml por kilogramo a pasar en bolo** (opción **D**). Tiene estado hemodinámico límite, pero el sopor obliga a hidratar por vía endovenosa, con plan C. Complicaciones Fetales / Neonatales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 161 2.01.2.006 · Deshidratación

Un lactante de 11 meses presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante, asociada a decaimiento marcado y tendencia al llanto. Al examen físico está somnoliento, con frialdad de extremidades y el llene capilar es de 3 segundos. Las mucosas se observan secas. ¿Cuál es la indicación inicial para su hidratación?

A) Sales de hidratación oral
B) Suero salino al 0,9%
C) Suero glucosado al 5%
D) Suero glucosalino
E) Albúmina endovenosa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto por el compromiso de conciencia, como por el compromiso hemodinámico (signos de shock hipovolémico: palidez y llene capilar lento) tiene indicación de hidratación endovenosa con suero fisiológico (plan C).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 65 2.01.2.006 · Deshidratación

Un lactante de 10 meses es llevado por su madre al servicio de urgencia, debido a vómitos y diarrea abundante desde hace 24 horas. En el examen Fsico llora sin lágrimas, se observa irritable y sus signos vitales muestran frecuencia cardíaca 150 la8dos por minuto y presión arterial 96/68 mmHg. Su peso actual es de 9.300 g, con registro de peso previo hace 6 días de 10 kg. El examen abdominal muestra abdomen sensible sin signos peritoneales y aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar gastroclisis con sales de rehidratación
B) Administrar bolo endovenoso de 20 cc/kg de suero hipertónico
C) Administrar an2emé2cos y enviar a domicilio con hidratación oral
D) Hidratar con sales de rehidratación por vía oral
E) Administrar bolo endovenoso de 20 cc/kg de solución salina al 0,9%

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una diarrea aguda con deshidratación moderada, por lo que se trata con “plan B”, consistente en sales de rehidratación oral, 50-100 cc/Kg en la misma urgencia y reevaluar en 4-6 horas. Al bajar 700 gramos, de un total de 10 kilogramos, corresponde al 7% del peso corporal. La deshidratación se considera leve si es menor al 5%, moderada entre 5% y 10% y severa si es mayor al 10% o si Gene compromiso hemodinámico. En este caso hay taquicardia, pero su presión arterial es incluso alta para la edad. El hecho de llorar sin lágrimas y la irritabilidad son características de la deshidratación moderada.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 94 2.01.1.093 · Infecciones osteoarticular

Un niño de 6 años consulta por dolor en el codo derecho, de dos días de evolución, asociado a impotencia funcional y fiebre de hasta 39ºC. Al examen físico, se observa codo eritematoso y aumentado de volumen, con dolor intenso a la movilización activa y pasiva. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Staphilococcus aureus
B) Haemophilus influenzae
C) Streptococcus agalactiae
D) Neisseria meningitidis
E) Streptococcus pyogenes

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una artritis séptica de codo (monoartritis aguda en niño). La etiología más frecuente es el estafilococo áureo en todas las edades, ya que el gonococo ha disminuido mucho (eso sí, aún debe tenerse como opción en pacientes con conductas sexuales de riesgo o con clínica de gonorrea).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 142 2.01.1.093 · Infecciones osteoarticular

Lactante de 6 meses, es traída por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por rechazo alimentario, irritabilidad y decaimiento, asociado a inmovilidad de extremidad inferior izquierda. Al examen se encuentra con temperatura de 38,5ºC y se aprecia cadera izquierda en flexión, con mucho dolor a la movilización. El examen inicial más adecuado en este caso es:

A) Hemograma con VHS
B) Radiografía de pelvis
C) Ecografía de cadera
D) Cintigrafía ósea
E) Resonancia magnética de cadera

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una artritis séptica, por lo que la respuesta debería ser punción. La pregunta es capciosa. Que diga "examen inicial" hace orientar más al hemograma. Esta niña probablemente irá directo a pabellón. La Eco sirve para guiar la punción. No estoy seguro de cuál es la respuesta correcta.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 105 2.01.1.093 · Infecciones osteoarticular

Una niña de 5 años presenta dolor en muslo izquierdo, que luego se ubica en la cadera izquierda y que limita su movimiento. Al examen físico está en buenas condiciones. El diagnóstico más probable es:

A) Sinovitis transitoria
B) Atritis séptica
C) Artritis reumatoidea
D) Osteomielitis
E) Tumor de Ewing

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la sinovitis transitoria suele ser en menores de 5 años, la clínica es compatible, por estar en buenas condiciones.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 72 2.01.1.006 · Coqueluche

Un recién nacido de 2 semanas es hospitalizado por presentar apneas. La madre re- fiere tos de 3 semanas de evolución, en crisis, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

A) Amoxicicilina
B) Azitromicina
C) Ceftriaxona
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Azitromicina** (opción **B**). La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.. Diagnóstico de elección: PCR para Bordetella pertussis; cultivo es poco sensible (bacteria fastidiosa) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 151 2.01.1.006 · Coqueluche

Un paciente de 13 meses, es traído por presentar desde hace 4 días cuadro caracterizado por crisis de tos que aparecen de forma repetitiva durante el día, asociado a decaimiento, rechazo alimentario, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecia hemorragia subconjuntival derecha, examen pulmonar con murmullo pulmonar presente, sin otros hallazgos. El agente etiológico más probable en este caso es:

A) Virus respiratorio sincicial
B) Virus parainfluenza
C) Mycoplasma
D) Bordetella pertusis
E) Virus sarampión

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Bordetella pertusis). Es un coqueluche de libro. El coqueluche (tos ferina o tos compulsiva) es una enfermedad incluida en el Plan Nacional de Inmunizaciones causada por Bordetella pertussis. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 40 2.01.1.006 · Coqueluche

Un recién nacido de 3 semanas de vida es hospitalizado por presentar apneas. La madre refiere tos frecuente de 2 semanas de evolución, intensa, que en ocasiones la hacen vomitar. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado?

A) Amoxicicilina
B) Azitromicina
C) Ceftriaxona
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Azitromicina** (opción **B**). La sospecha es un coqueluche, que se trata con macrólidos.. Diagnóstico de elección: PCR para Bordetella pertussis; cultivo es poco sensible (bacteria fastidiosa) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 151 2.01.1.006 · Coqueluche

Un niño de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea y tos, que va en aumento, hasta presentar accesos de tos y dificultar la alimentación. Al examen físico está en buenas condicioness generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis de 17.000, con 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. La PCR y VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial leve. El diagnóstico más probable es:

A) Neumonía atípica
B) Infección por virus influenza
C) Infección por adenovirus
D) Coqueluche
E) Bronquiolitis aguda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un coqueluche clásico: tos en accesos, precedido por cuadro catarral y linfocitosis en el hemograma.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 45 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Un niño de 4 años presenta un cuadro de fiebre hasta 39,5 grados, asociada a tos con expectoración mucupurulenta, de 2 días de evolución. Además refiere cefalea y marcado malestar general. Al examen físico está decaído, febril, con FC:100x', RR2T, sin soplos, examen pulmonar con presencia crepitaciones localizadas en la zona superior

A) Mycoplasma pneumoniae
B) Chlamydia pneumoniae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Haemophilus influenzae
E) Staphilococcus aureus

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Streptococcus pneumoniae). Es una NAC neumocócica clásica.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 8 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Un recién nacido de 2 meses de edad, presenta un cuadro de tos con expectoración, asociado a taquipnea. Al examen físico, tiene T°: 38,5°C, frecuencia cardíaca de 100 x' y frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturando 91% a FiO2 ambiental. Su examen pulmonar solo muestra crepitaciones bilaterales. Como antecedentes, nació por parto vaginal y sufrió una conjuntivitis neonatal con secreción serosa a los 15 días de vida, la que fue tratada exitosamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cardiopatía congénita
B) Infección por estreptococo grupo B
C) Fibrosis quística
D) Infección por Streptoccus pneumoniae
E) Infección por Chlamydia trachomatis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Infección por estreptococo grupo B** (opción **B**). Positiva (parto progresa) → continuar vía vaginal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 157 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Un paciente de 7 años, con historia de 8 días de tos y coriza, sin otros síntomas, presenta desde hace 24 horas aumento de su tos asociado a expectoración mucopurulenta, dificultad respiratoria y sensación febril. Al examen físico se encuentra decaído, con temperatura de 38ºC, su examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente de forma bilateral, asociado a estertores y sibilancias difusas. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Claritromicina
B) Amoxicilina
C) Amoxicilina con ácido clavulánico
D) Acetaminofeno y salbutamol
E) Cefadroxilo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Claritromicina** (opción **A**). Es una NAC atípica. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 43 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Un niño de 8 años presenta, desde hace dos semanas de odinofagia, rinorrea y tos, a lo que se le ha agregado disnea progresiva y fiebre hasta 38,5°C. Hace dos días se agrega un exantema eritematoso polimorfo. Al examen físico destacan crepitaciones y sibilancias bilaterales, difusas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina más ácido clavulánico
C) Claritromicina
D) Oseltamivir
E) Aciclovir

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae. Recordar que puede hacer un exantema eritematoso o un eritema multiforme menor (más frecuentemente el EMM se produce por infección por herpes o por medicamentos).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 108 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Una niña de 7 años presenta un cuadro de 4 días de evolución con fiebre alta, tos con expectoración mucopurulenta, a lo que se agregó dolor torácico con la inspiración profunda y, recientemente, también dolor abdominal y deposiciones diarreicas. Al examen físico, está febril con T°: 38,8°C, con frecuencia cardíaca: 110x' y, en su examen cardiopulmonar se ausculta murmullo pulmonar disminuido bilateralmente, abolido en la base derecha, con crépitos en esa zona. El examen abdominal muestra dolor difuso a la palpación profunda, sin signos peritoneales y se ausculta aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuál de los siguientes es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) Videotoracoscopía
C) Radiografía de tórax lateral en decúbito lateral
D) TAC de tórax
E) Radiografía de tórax anteroposterior y lateral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Neumonía y Dolor Abdominal: El paciente presenta un cuadro clínico de neumonía clásica. Es importante tener en cuenta que la neumonía puede manifestarse con dolor abdominal y otros síntomas abdominales. Por lo tanto, el examen inicial a realizar es una radiografía de tórax anteroposterior y lateral.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 15 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Niña escolar con tos seca, crepitaciones bilaterales e infiltrados intersticiales en la radiografía de tórax. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Mycoplasma pneumoniae
C) Virus sincicial respiratorio
D) Haemophilus influenzae
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Mycoplasma pneumoniae). Mycoplasma pneumoniae. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Streptococcus pneumoniae, Virus sincicial respiratorio) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 157 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Un niño de 7 años presenta rinorrea y tos de 9 días de evolución, que han aumentado y se asociaron a disnea, progresiva y fiebre hasta 38,2°C. Al examen físico presenta T°C: 37,5°C, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, murmullo pulmonar bilateral, simétrico, algo diminuido, con sibilancias y crepitaciones bilaterales. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Mycoplasma pneumoniae
B) Streptococcus pyogenes
C) Bordetella pertusis
D) Virus parainfluenza
E) Virus respiratorio sincicial

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una neumonía atípica, que suelen ser causadas por mycoplasma y son muy frecuentes en la edad escolar.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 16 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Niño de 2 meses con conjuntivitis a los 12 días, luego tos seca, crepitaciones y sibilancias. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Mycoplasma pneumoniae
C) Virus sincicial respiratorio
D) Ureaplasma urealyticum
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Chlamydia trachomatis). Chlamydia trachomatis. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 19 2.01.1.024 · Infecciones respiratorias

Una niña de 7 años presenta un cuadro de 9 días de tos disfónica, a lo que, en los últimos días, se agrega astenia, malestar general, dificultad respiratoria y fiebre hasta 38,5°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con frecuencia cardíaca: 90x', saturación arterial 95% y T°:38°C. Tiene faringe eritematosa, sin exudado. Al examen pulmonar, se auscultan sibilancias y crepitaciones bilaterales. Se solicita una radiografía, que muestra múltiples infiltrados pulmonares bilaterales, con atelectasias lineales en las bases. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Adenovirus
B) Virus parainfluenza
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Streptococcus pneumoniae
E) Bordetella pertusis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Mycoplasma pneumoniae). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Adenovirus, Virus parainfluenza) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 173 2.01.1.052 · Insuficiencia cardíaca

Lactante de 4 meses de edad, sin antecedentes conocidos, alimentado con lactancia materna de forma exclusiva, es traído por presentar bajo incremento ponderal, asociado a cansancio al alimentarse y decaimiento. Se aprecia decaído, saturación arterial de 90%, examen cardiaco con ritmo regular en dos tiempos, con presencia de soplo sistólico, y pulmonar que muestra murmullo pulmonar disminuido en bases, asociado a crepitaciones finas bilaterales. El manejo inicial más adecuado en este caso es:

A) Administrar furosemida endovenosa
B) Administrar vasodilatadores endovenosos
C) Administrar epinefrina endovenosa
D) Realizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica
E) Administrar betabloqueadores endovenosos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hay que hacer una eco por la Cardiopatía congénita. Probable EPA: En lactantes están contraindicados los vasodilatadores, porque empeoran cortocircuito de Izquierda a derecha, al disminuir la resistencia vascular pulmonar. Se prefiere la furosemida.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 175 2.01.1.026 · Otitis media

Un paciente de 3 años, sin antecedentes, con cuadro de rinofaringitis viral de dos días de evolución en tratamiento sintomático, es traído por presentar desde hace unas horas mayor compromiso del estado general, asociado a otalgia intensa izquierda y sensación febril. Al examen físico destaca examen cardiopulmonar normal y a la otoscopía se aprecia tímpano izquierdo eritematoso y abombado con escasa secreción purulenta. El fármaco de elección en este caso es:

A) Ibuprofeno oral
B) Amoxicilina oral
C) Amoxicilina con ácido clavulánico oral
D) Gentamicina tópica
E) Claritromicina oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una OMA: amoxi sola. En la OMAR también es amoxi sola. Solo si no responde en 72 horas, se agrega ácido clavulánico.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 13 2.01.1.026 · Otitis media

Un niño de 3 años presenta un cuadro de 5 días de evolución de rinorrea, fiebre y odinofagia, al que, hace dos días se le agrega otalgia, por lo que se realiza otoscopía que muestra tímpano abombado y eritematoso. Se inicia amoxicilina 50 mg/kg al día, sin embargo, a las 48 horas no ha mostrado ningún tipo de mejoría. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis a 100 mg/Kg al día
B) Cambiar el tratamiento a azitromicina oral 10 mg/Kg al día
C) Agregar ácido clavulánico al tratamiento oral
D) Solicitar una TAC de peñasco
E) Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tratamiento en Otitis Media Aguda: La dosis recomendada de amoxicilina para esta condición es de 80 a 100 mg por kilogramo al día. Si en 48-72 horas no responde a la dosis adecuada, se debe agregar ácido clavulánico. En este caso, la dosis dada fue inferior, por lo que una respuesta potencialmente correcta también sería indicar la dosis recomendada actualmente. Es más, en la práctica médica, probablemente se hagan ambas cosas. Debido a que los gérmenes más frecuentes son neumococo, que en las infecciones extrameníngeas tiene muy baja tasa de resistencia a penicilinas y luego Moraxella y Haemophilus, que producen betalactamasas, recomendamos agregar el ácido clavulánico. Sin embargo, es una pregunta muy difícil.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 180 2.01.1.077 · Cefalea

Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea frontotemporal intensa, de tipo pulsátil, asociado a fotofobia y fonofobia. Refiere que desde los cinco años ha presentado cuadros similares, y que durante el último año ha presentado cinco episodios. El diagnóstico más probable es:

A) Migraña clásica
B) Cefalea en racimos
C) Cefalea tensional
D) Migraña complicada
E) Tumor cerebral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Migraña clásica** (opción **A**). Migraña con aura clásica Clave Eplicación. 1. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Cefalea en racimos, Cefalea tensional) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 85 2.01.1.032 · Leucemias

Una niña de 9 meses de edad, estuvo alimentada con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, momento en que inició la alimentación sólida. Sin embargo, la madre, vegana estricta, consideró que la niña no toleraba bien los alimentos, por lo que la mantuvo con leche materna exclusiva hasta ahora. Evoluciona con detención del crecimiento, dificultades para sentarse y hablar, además de estar más hipoactiva de lo normal. Al examen físico, se aprecia pálida y letárgica, con signos vitales normales y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar ni abdominal. Se solicitan exámenes, que muestran hemoglobina: 7,9 g/dl, hematocrito: 24%, blancos: 3.700 por mm3, plaquetas: 45.000 por mm3, VHS: 12 mm/h, TSH: 1,2 UI/L, creatininemia: 0,5 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Déficit de vitamina B12
B) Anemia hemolítica
C) Enfermedad celíaca
D) Leucemia aguda
E) Fibrosis quística

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Leucemia aguda** (opción **D**). :::note Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 27 2.01.1.032 · Leucemias

Un niño de 8 años presenta dolores óseos generalizados, asociada a malestar general y fiebre de 3 semanas de evolución. Al examen físico se palpa el bazo aumentado de tamaño e indurado, se constatan poliadenopatías indoloras y se observan petequias y equimosis generalizadas, mayores en las extremidades inferiores ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Cintigrafía ósea
B) Hemograma
C) Biopsia esplénica
D) Mielograma
E) Cuantificación de inmunoglobulinas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una probable leucemia aguda. Si bien el examen inicial es el mielograma, el que confirma (lo que se pregunta) es la biopsia de médula ósea y también sirve el mielograma (frotis de médula ósea).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 15 2.01.1.032 · Leucemias

Un niño de 11 años presenta un cuadro de astenia y fiebre de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia palidez, asociado a esplenomegalia. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para continuar el estudio en este paciente?

A) IgM para virus Ebstein Baar
B) Hemograma VHS
C) Biopsia ganglionar
D) IgM para Bartonella henselae
E) Tiempos de coagulación

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Hemograma VHS). Probable leucemia aguda. Se inicia el estudio con Hemograma. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 158 2.01.1.032 · Leucemias

Un niño de 10 años es traído a la consulta por aparición de múltiples equimosis y petequias, desde hace 2 semanas, asociadas a palidez. Al examen físico se aprecia pálido, con petequias en las extremidades inferiores y el tronco y múltiples equimosis de gran tamaño en las extremidades inferiores. Además, se palpa hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde costal. El diagnóstico más probable es:

A) Púrpura trombopénica inmune
B) Enfermedad de von Willebrand
C) Púrpura de Schönlein Henoch
D) Meningococcemia
E) Leucemia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una leucemia clásica, con signos de insuficiencia medular (anemia y alteraciones de la hemostasia primaria) y hepatoesplenomegalia. Ninguna de las otras tiene anemia. La meningococcemia es muy agresiva, en cosa de horas o pocos días. La PSH tiene púrpura palpable, alteraciones digestivas, compromiso articular y GNA. la EvW es algo crónico con alteración de la hemostasia primaria. La PTI sí puede tener equimosis y petequias, pero no la hepatomegalia.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 19 2.01.1.073 · Diabetes

Un paciente de 12 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a bajo de peso, que en las últimas horas se le agrega poliuria importante. Consulta porque en las últimas horas se agrega gran compromiso del estado general, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está taquicárdico, soporoso, con polipnea y signos de deshidratación. En sus exámenes presenta glicemia de 470 mg/dl, sodio de 143 mEq/L, potasio de 4,8 mEq/L, cloro de 97 mEq/L, bicarbonato de 12 mEq/L y pH de 7,05. ¿Qué fluido debe administrarse a este paciente?

A) Suero glucosado
B) Suerlo glucosalino
C) Solución salina al 0,45%
D) Solución salina al 0,9%
E) Suloción ringer lactato

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La cetoacidosis se hidrata con suero fisiológico. Sin embargo la opción del Ringer Lactato es una respuesta totalmente correcta. Pero suero NaCl al 0,9% será la respuesta correcta.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 41 2.01.1.073 · Diabetes

Un niño de 11 años es llevado al servicio de urgencia por sus padres, debido a que presenta compromiso de conciencia desde hace algunos minutos. Sus padres refieren que desde hace 4 días presenta poliuria, polidipsia y malestar general. Al examen Fsico destaca frecuencia cardíaca: 150 lpm, presión arterial: 100/60 mmHg, temperatura: 37°C y sopor superficial. En la exploración neurológica no 8ene signos focales. Entre los exámenes de laboratorio destacan glicemia: 320 mg/dL; gases venosos con pH: 7,11, bicarbonato plasmá8ca: 12 mEq/L, exceso de base: -9, $PaCO_2$: 24 mmHg; cetonemia y cetonuria posi8vas; sodio plasmá8co: 145 mEq/L, potasio plasmá8co: 5,1 mEq/L y crea8nina plasmá8ca: 1,8 mg/dL. ¿Cuál es la primera medida a administrar?

A) Suero fisiológico 20 cc/kg endovenoso
B) Insulina endovenosa
C) Adrenalina endovenosa
D) Cloruro de potasio intravenoso
E) Oxígeno por mascarilla de recirculación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una cetoacidosis diabética (CAD), en contexto de una diabetes mellitus 1, que está debutando. El suero fisiológico (SF) siempre es la primera medida y se puede dar incluso antes del resultado de los gases venosos y los electrolitos plasmáticos. La insulina EV también se debe administrar, aunque está contraindicada si el potasio está bajo (K+ < 3,2 mEq/L en la CAD), ya que la insulina EV baja la potasemia y Gene riesgo de arritmias graves. El cloruro de potasio (KCl) también se administrar (en goteo, nunca en bolo), ya que la insulina baja la potasemia, aunque está contraindicado si la potasemia está elevada (K+ > 5,2 mEq/L en la CAD). El bicarbonato (fíaHCO3) EV se indica solo si el pH es < 6,9, ya que la corrección agresiva de la acidosis se asocia a edema cerebral. En resumen: K+: > 5,2 = SF + insulina. No KCl. K+: 3,2 a 5,2 = SF + insulina + KCl (este caso). K+ < 3,2 = SF + KCl (mayor dosis). No insulina.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 100 2.01.1.073 · Diabetes

Cabro chico dm 1 con CAD, PA 90/60, FC 80, conducta inicial:

A) bolo 20mg kg en 30 min b. bolo 10ml/kg en 1 horas (puse esta porque para los signos vitales a su edad no estaba shockeado)
C) Insulina
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **bolo 20mg kg en 30 min b. bolo 10ml/kg en 1 horas (puse esta porque para los signos vitales a su edad no estaba shockeado)** (opción **A**). Comparación de las 3 Patologías De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 21 2.01.1.081 · Síndrome convulsivo

Un niño de 7 años presenta episodios en los que se queda quieto, mirando fijo, los que luego no recuerda. Han aumentado en frecuencia, hasta suceder 5 veces al día. El resto de su examen físico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síncompes vasovagales
B) Epilepsia mioclónico
C) Crisis de ausencia
D) Epilepsia focal
E) Déficit atencional

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Crisis de ausencia** (opción **C**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 78 2.01.1.081 · Síndrome convulsivo

Un niño de 7 años es traído por su madre, porque presenta mal rendimiento escolar. Tiene un hermano con déficit atencional diagnosticado. Durante el examen, presenta un breve episodio de desconexión con el medio. ¿Con que examen se debe continuar el estudio de este paciente?

A) Psicometría
B) Evaluación psicopedagógica
C) Electroencefalograma
D) TAC cerebral
E) Audiometría

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una probable epilepsia por crisis de ausencia. Se estudia con EEG, al igual que las demás epilepsias primarias. Su hermano también debería estudiarse.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 77 2.01.1.081 · Síndrome convulsivo

Un niño de 10 años convulsiona a la mañana siguiente, de haber trasnochado jugan- do videojuegos. Además refiere mioclonías matinales frecuentes, desde hace algunos meses. Su examen físico es normal, al igual que su examen neurológico. ¿Cuál es la me- dida más adecuada?

A) Prohibir por completo los videojuegos
B) Iniciar ácido valproico
C) Iniciar carbamazepina
D) Iniciar fenobarbital
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una probable epilepsia mioclónica, que se trata preferentemente con ácido val- proico. Sí pueden jugar videojuegos, pero con pantallas e iluminación adecuadas y por ciertos horarios limitados. Es una pregunta que excede los conocimientos de un médico general.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 157 2.01.1.015 · Meningoencefalitis/ Mening

Un niño de 8 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre de 2 días de evolución, a lo que se agrega una conducta agresiva y luego desorientación. Convulsiona en varias oportunidades. Su TAC descarta hipertensión endocraneana, por lo que se realiza punción lumbar que da salida a líquido cefalorraquídeo con 100 glóbulos rojos por mm3, 20 glóbulos blancos por mm3, con 90% de mononucleares, proteínas: 80 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A) Oseltamivir
B) Vancomicina
C) Ceftriaxona
D) Aciclovir
E) Ampicilina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una meningitis herpética, que se trata con aciclovir EV. Tanto la clínica, como el LCR viral (predominio MN y glucosa normal) hemorrágico la sugieren.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 22 2.01.1.015 · Meningoencefalitis/ Mening

Un niño de 4 años, con antecedente de una convulsión febril hace 2 años, presenta un cuadro de fiebre y cefalea, seguido luego de deterioro del estado general y compromiso de conciencia. Luego, convulsiona en una oportunidad. Se realiza una punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo, con glucosa de 68 mg/dl, 62 mg/dl de proteínas, 300 glóbulos blancos, con 80% mononuclear y 60 glóbulos rojos, crenados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Encefalitis herpética
B) Hemorragia subaracnoidea
C) Meningitis bacteriana
D) Meningitis tuberculosa
E) Convulsión febril benigna

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un LCR de meningitis viral (mononuclear con glucosa mayor a 35), además hemorrágico (hematíes crenados: no es sangrado por la punción). La clínica grave orienta a herpes.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 65 2.01.1.015 · Meningoencefalitis/ Mening

Un niño de 3 años, con antecedente de una convulsión febril a los 10 meses de edad, autolimitada, presenta fiebre, de 3 días de evolución, asociada a convulsión en dos oportunidades y desorientación. Se realiza punción lumbar, que da salida a líquido cefalorraquídeo, con glucosa 76 mg/dl (glicemia: 96 mg/dl), 210 células por mm3, con 85% de mononucleares, con 70 glóbulos rojos por mm3, 80% crenados y proteínas de 73 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Meningitis bacteriana
B) Epilepsia
C) Meningitis por enterovirus
D) Encefalitis herpética
E) Hemorragia subaracnoidea

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto la clínica (convulsiones y desorientación) como el LCR (líquido hemorrágico: GR crenados, con característica virales: glucosa normal y pleocitosis de predominio mononuclear), sugieren encefalitis herpética. Falta la imagen con las lesiones en los lóbulos temporales.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 64 2.01.1.068 · Síndrome nefrítico

Un niño de 7 años presenta edema de párpados y de EEII, asociado a orinas oscuras. Al examen tiene edema de párpados y de ambas piernas, con presión arterial de 127/85. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome nefrítico
B) Síndrome nefrótico
C) Efermedad de Berger
D) Necrosis tubular aguda
E) Síndrome hemolítico urémico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome nefrítico** (opción **A**). Cuadro clásico (HTA + edema + hematuria). Esa PA es muy alta para un niño de esa edad. :::note Agonistas de GnRH: La GnRH fisiológica es pulsátil. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 47 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Un niño de 5 años, al que le molestan los ruidos fuertes, presenta vocabulario muy escaso. Caminó a los 24 meses y dijo su primera palabra a los 36 meses. No pareciera tener interés en relacionarse con los demás niños de su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional
B) Trastorno generalizado del desarrollo
C) Parálisis cerebral
D) Distrofia muscular
E) Trastorno del lenguaje

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un trastorno del espectro autista clásico, de la variante autista (Asperger, en cambio, tiene lenguaje normal). Además, afecta otras áreas del desarrollo, por lo que antes se les llamaba trastornos generalizados del desarrollo.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 37 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Niña que no se comunica con compañeros, responde agresivamente ante cambios en sus rutinas y guarda muñecas sin jugar con ellas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional con hiperactividad
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno del espectro autista
D) Trastorno de conducta
E) Retraso global del desarrollo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno del espectro autista** (opción **C**). Trastorno del espectro autista. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 78 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Un niño de 5 años presenta movimientos repetitivos con las manos, estereotipados (manierismos), no habla y solo se comunica con señas, no se relaciona con otros niños y llora cuando le quitan el sombrero. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno generalizado del desarrollo
B) Trastorno por déficit atencional
C) Trastorno de conducta
D) Hipotiroidismo congénito
E) Epilepsia generalizada

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un autismo también (recordar que el autismo pertenece a los trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 74 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Un niño de 3 años y 2 meses, hijo único, de padres no consanguíneos, está en terapia de lenguaje, desde hace 6 meses, sin mayores logros. Acude al jardín infantil y el padre lo describe como tímido y poco sociable. Además, tiene un juguete que hace ruido, con el que juega solo. Su desarrollo motor es normal. El diagnóstico más probable es:

A) Privación social
B) Hipoacusia
C) Discapacidad intelectual
D) Trastorno por déficit atencional, sin hiperactividad
E) Trastorno del espectro autista

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno del espectro autista** (opción **E**). Es un TEA clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 140 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Un niño de 4 años presenta retraso generalizado del desarrollo psicomotor. Solo dice 4 palabras inteligibles. Además realiza movimientos estereotipados de rotación y manierismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Distrofia muscular de Duchenne
B) Síndrome de Gilles de la Tourette
C) Trastorno del espectro autista
D) Parálisis cerebral
E) Síndrome de West

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno del espectro autista** (opción **C**). Es un TEA clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 77 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Un niño de 4 años no tiene interés en juntarse con otros niños, no habla y solo se comunica con señas. Aplaude con frecuencia, ante situaciones estresantes, no le gusta que lo toquen y juega siempre con el mismo juguete. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno global del desarrollo
B) Trastorno del espectro autista
C) Hipoacusia
D) Parálisis cerebral
E) Trastorno de conducta

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Trastorno del espectro autista** (opción **B**). Es un autismo. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 35 · 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Una niña de 3 años no juega con sus compañeros del jardín infantil, tampoco le responde a la profesora e, incluso, la agredió en un momento, cuando la obligaron a cambiar de una actividad que hacían rutinariamente. Su madre refiere que, en casa, habla poco, le gusta ordenar sus juguetes siempre de la misma forma y no demuestra interés en jugar con los demás niños del barrio y que se lleva frecuentemente las manos a los oídos, especialmente cuando hay ruidos fuertes, como los del secador de pelo o la aspiradora, que le son especialmente molestos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Discapacidad cognitiva
B) Trastorno del espectro autista
C) Hipoacusia congénita
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno por déficit atencional hipoactivo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Discapacidad cognitiva** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 79 · 2.01.1.141 · Trastornos del desarrollo

Un niño de 2 años y 8 meses realiza rabietas con frecuencia, se tira al suelo y grita cuando no se hace lo que él quiere, lo que ha pasado frente a sus padres y las profeso- ras del jardín infantil. Dice 300 palabras y su desarrollo motor es acorde a su edad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno oposicionista desafiante
B) Trastorno de conducta
C) Trastorno por déficit atencional
D) Trastorno generalizado del desarrollo
E) Oposicionismo normal para su desarrollo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Oposicionismo normal para su desarrollo** (opción **E**). Por la edad y la intensidad de las rabietas, parece un niño normal.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 87 · 2.01.1.085 · Trastornos aprendizaje

Un niño de 7 años perdió el año escolar. Presenta dificultades en la lectoescritura, invierte fonemas con frecuencia, es muy lento para leer y le cuesta deletrear. Su padre no terminó el colegio, porque tenía problemas similares. El diagnóstico más probable es:

A) Coeficiente intelectual límite
B) Trastorno oposicionista desafiante
C) Trastorno por déficit atencional
D) Dislexia
E) Trastorno del desarrollo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Dislexia** (opción **D**). Cuadro clásico. Causas: 1. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Coeficiente intelectual límite, Trastorno oposicionista desafiante) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 83 · 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares

Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente la visión. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Administrar propanolol
B) Administrar betametasona
C) Realizar embolización
D) Derivar a cirujano plástico
E) Observar evolución

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El propanolol es el tratamiento de primera línea de los hemangiomas infantiles. La cirugía solo se hace en casos que no responden y sabiendo que dejará cicatriz con certeza.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 126 · 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares

Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Solicitar ecografía abdominal
B) Iniciar propranolol oral
C) Iniciar corticoides intralesionales
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de cerebro
E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hemangiomas Infantiles: La presencia de múltiples hemangiomas infantiles obliga a descartar hemangiomas viscerales con una ecografía abdominal. El propranolol oral es el tratamiento de elección para los hemangiomas complicados o deformantes.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 19 · 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares

Niño con 6 hemangiomas en tronco y extremidades. ¿Qué examen solicitar inicialmente?

A) RNM de cerebro
B) TAC de tórax
C) Gammagrafía ósea
D) Ecografía abdominal
E) Angiografía por resonancia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Ecografía abdominal). Ecografía abdominal. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (RNM de cerebro, TAC de tórax) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 87 · 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares

Un recién nacido de 5 días de vida tiene un hemangioma en el párpado izquierdo, de 1 cm de diámetro, que cubre parcialmente el iris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observar evolución
B) Indicar propanolol oral
C) Indicar corticoides orales
D) Biopsiar
E) Derivar a cirujano plástico infantil

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La primera medida ante los hemangiomas infantiles es dar propanolol. Si no involucionan, en casos como este está indicada la cirugía (porque deforma la cara, produce ambliopía, etc).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 41 · 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares

Una recién nacida de 27 días de vida presenta 6 hemangiomas superficiales, en el tronco y extremidades. El resto de su examen físico es normal y no tiene antecedentes de importancia. ¿Cuál examen es más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente?

A) Ecografía abdominal
B) Ecografía cerebral
C) Resonancia magnética nuclear espinal
D) Ecografía de partes blandas
E) Resonancia magnética nuclear de cerebro

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Resonancia magnética nuclear espinal). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecografía abdominal, Ecografía cerebral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 90 · 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares

Un niño de 7 meses nació con una mácula eritematosa, de tres cm, en la mano izquierda, la que ha ido creciendo en tamaño y espesor. Actualmente se ve de la siguiente forma: FOTO: No encontré fotos en internet, pero la imagen era una placa, que afectaba el dorso de la mano, de color rojo, de 1 mm de alto y de 4 a 5 cm de largo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observar evolución
B) Corticoides orales
C) Corticoides locales
D) Propanolol
E) Cirugía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy difícil. Es una malformación vascular (mácula presente al nacimiento. No ha crecido mucho). No es un hemangioma. La mayoría se observa, aunque lo más importante es pedirle un ecodoppler, para determinar qué hacer exactamente (observar, cirugía o láser).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 91 · 2.01.1.111 · Malformaciones vasculares

Un recién nacido sufre la caída del cordón umbilical, presentado a los pocos días una lesión redondeada y solevantada, no pediculada, de color rosado brillante y aspecto húmedo, de 1 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo?

A) Corticoides tópicos
B) Resolución quirúrgica
C) Nitrógeno líquido
D) Aplicación de nitrato de plata
E) Antibióticos tópicos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un granuloma umbilical, cuyo tratamiento de elección es el "nitrato de tocarlo", es decir, nada. Sin embargo, como opción, se puede dar nitrato de plata, para cauterizarlo. El procedimiento no duele.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 122 · 2.01.1.016 · Mononucleosis infecciosa

Un niño de 3 años, con un cuadro de fiebre alta, asociada a malestar general y odinofagia intensa. Se inició tratamiento con amoxicilina, pero a las 48 horas presenta un exantema, que se muestra más abajo. Al examen físico, se aprecia decaído, con adenopatías cervicales anteriores dolorosas y amígdalas edematosas y eritematosas, con exudado blanco en su superficie. El exantema se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Escarlatina
B) Mononucleosis infecciosa
C) Alergia a la penicilina
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Sarampión

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una mononucleosis clásica, dado que tiene el síndrome mononucleósico (odinofagia, fiebre y adenopatías), más el clásico rash morbiliforme (similar al sarampión), que aparece luego de iniciar aminopenicilinas (ampicilina o amoxicilina). También es clásico el exudado amigdalino blanco y adherente sobre la superficie amigdalina. La escarlatina tendría clínica de amigdalitis bacteriana (ya explicada en otra pregunta) y un exantema en piel de gallina, con especial afectación de pliegues cubitales y que respeta el triángulo de Filatov. La enfermedad de Kawasaki no suele tener odinofagia ni exudado amigdalino, sino fiebre, adenopatías, ojo rojo, boca roja, rash de cualquier tipo (salvo vesicular o pustular) y compromiso de pies y manos.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 129 · 2.01.1.016 · Mononucleosis infecciosa

Un niño de 7 años de edad presenta un cuadro de fiebre y odinofagia, asociado a malestar general. Al examen físico presenta faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y se palpa adenopatía cervical, por lo que se inicia amoxicilina oral. Dos días después evoluciona con un exantema, que se muestra en la FOTO. El diagnóstico más probable es: NOTA: la foto original era de un niño, pero el exantema es muy similar a este (fue la foto más parecida que hallé en Google)

A) Escarlatina
B) Reacción alérgica a la amoxicilina
C) Eritema multiforme menor
D) Artritris reumatoide juvenil
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Mononucleosis infecciosa** (opción **E**). Tiene la clínica de mononucleosis clásica. El rash post-ampicilina es clásico también.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 86 · 2.01.1.016 · Mononucleosis infecciosa

Un niño de 11 años presenta fiebre de 10 días de evolución, asociado a astenia, cefalea, malestar general y odinofagia. Al examen físico tiene FC: 90x', T°: 37,9°C, faringe congestiva y se palpan adenopatías cervicales anteriores múltiples de 0,5 cm. En el examen abdominal, tanto el hígado como el bazo se palpan 2 cm por debajo del reborde costal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Coprocultivo
B) Hemocultivos
C) Serología para Brucella
D) IgM para virus hepatitis A
E) Anticuerpos heterófilos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Coprocultivo** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Hemocultivos, Serología para Brucella) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 110 · 2.01.1.023 · Faringoamigdalitis

Un niño de 18 meses presenta dolor de garganta y fiebre de 2 días de evolución de hasta 39,0°C, asociado a irritabilidad, malestar general y secreción conjuntival bilateral. Al examen físico, además, se observa faringe eritematosa exudado amigdalino bilateral y se palpan adenopatías cervicales anteriores. El agente etiológico más probable es:

A) Staphilococcus aureus
B) Streptococcus pyogenes
C) Metaneumovirus
D) Adenovirus
E) Virus de Ebstein Baar

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La clásica amigdalitis exudativa en el menor de 3 años es por ADV. Suele tener fiebre alta y, en este caso, además, viene con la clásica fiebre faringoconjuntival por ADV. Si no hubiese tenido afectación ocular igual sería por ADV, así que a aprender este caso clínico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 75 · 2.01.1.023 · Faringoamigdalitis

Un niño de 2 años y 6 meses presenta fiebre, hasta 39°C, asociado a irritabilidad, odinofagia y malestar general. En su examen físico destacan adenopatías cervicales bilaterales y faringe eritematosa y congestiva, con abundante exudado amigdalino bilateral. La auscultación pulmonar muestra murmullo pulmonar presente, sin ruidos agregados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Amigdalitis estreptocócica
B) Mononucleosis infecciosa
C) Influenza
D) Infección por Streptococcus pneumoniae
E) Infección por adenovirus

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una infección clásica por adenovirus: recordar que antes de los 3 años son muy raras las amigdalitis bacterianas.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 131 · 2.01.1.023 · Faringoamigdalitis

Un paciente de 8 años presenta un cuadro de odinofagia de un día de evolución, intenso, asociado a fiebre. Al examen físico tiene faringe congestiva, con exudado amigdalino bilateral y presencia de una adenopatía cervical. Su hermano menor está en tratamiento por escarlatina confirmada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar amoxicilina oral
B) Solicitar test pack para estreptococo
C) Solicitar cultivo faríngeo
D) Solicitar IgM para virus Ebstein Baar
E) Indicar tratamiento sintomatico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una amigdalitis pultácea (por Streptococcus pyogenes). No tiene nada que oriente a etiología viral. La escarlatina del hermano es por el mismo agente, lo que hace sospecharla aún más. Se debe tratar, por la alta probabilidad de que sea pultácea.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 143 · 2.01.1.023 · Faringoamigdalitis

Un paciente de 8 años consulta por fiebre alta, asociada a odinofagia intensa. En su examen físico se aprecia faringe eritematosa, asociada a exudado bilateral. Se solicita una prueba rápida de detección de antígenos estreptocócicos, la que resulta positiva. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Amoxicilina
B) Amoxicilina + ácido clavulánico
C) Azitromicina
D) Clindamicina
E) Metronidazol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Amoxicilina** (opción **A**). La amoxicilina es el tratamiento de elección de la amigdalitis estreptococócica.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 107 · 2.01.1.023 · Faringoamigdalitis

Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de dos días de evolución, con escasa congestión nasal. Al examen físico se observan amígdalas edematosas y aumentadas de volumen, con exudado blanquecino en los surcos, adenopatías cervicales dolorosas y fiebre: 39°C. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar amoxicilina
B) Solicitar TAC de cuello
C) Iniciar cetriaxona
D) Iniciar tratamiento sintomático
E) Solicitar prueba rápida de detección de Streptococcus pyogenes

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Orienta a etiología bacteriana: 1. el dolor intenso, 2. el exudado característico, 3. las adenopatías, 4. la fiebre alta, 5. la edad (3 a 15 años) y la ausencia de sintomatología catarral. La congestión nasal suele orientar más a etiología viral, pero se describe como "escasa". Con ello, cumple 4 o 5 criterios para iniciar antibióticos (amoxicilina de elección). Con 0 o 1, se asume viral; con 2 o 3 se pide cultivo o test rápido; con 4+ se trata como bacteriana.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 107 · 2.01.1.023 Faringoamigdalitis

Un niño de 2 años consulta por odinofagia de 2 días de evolución, asociada a fiebre de 38,1 °C. En su examen Fsico presenta amígdalas eritematosas y aumentadas de tamaño, con exudado bilateral de aspecto purulento, y se palpan adenopa`as cervicales pequeñas bilaterales. Su examen cardiopulmonar es normal. Se solicita prueba de detección de estreptococo beta hemolí8co del grupo A, que resulta posi8va. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Azitromicina
B) Amoxicilina
C) Claritromicina
D) Amoxicilina + ácido clavulánico
E) Penicilina sódica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien es rara la amigdaliGs bacteriana en menores de 3 años, en este caso Gene 3 criterios de Centor (fiebre, exudado y adenopaVas), por lo que es correcto haberle pedido las pruebas de detección de SGA. Al estar positivas, se obliga al tratamiento antibiótico. De elección se usa la amoxicilina sola. El SGA no desarrolla betalactamasas, por lo que no es necesario el ácido clavulánico. La penicilina benzaGna en una dosis es una buena opción, aunque dolorosa, en cambio la penicilina sódica se debe dar cada 6 horas, por lo que no se usa en esta infección. Los macrólidos son de elección en alérgicos a la penicilina.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 144 · 2.01.1.023 Faringoamigdalitis

Un lactante de 10 meses, presenta fiebre de 4 días de evolución, de hasta 39,1°C, asociado a irritabilidad y malestar general. Al examen físico tiene secreción conjuntival bilateral, adenopatías cervicales anteriores y amígdalas con exudado blanquecino bilateral. El agente etiológico más probable es:

A) Streptococcus pneumoniae
B) Streptococcus pyogenes
C) Staphilococcus aureus
D) Adenovirus
E) Citomegalovirus

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es la clásica infección por ADV, en este caso con una fiebre faringoconjuntival. Es importante hacer notar que es la causa más frecuente de amigdalitis exudativa en el menor de 3 años, así que, incluso si no hubiese tenido una conjuntivitis, seguiría siendo una infección por ADV.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 28 · 2.01.1.023 Faringoamigdalitis

Un niño de 8 años presenta odinofagia intensa, de 48 horas de evolución, asociada a malestar general, fiebre hasta 39ºC, dolor abdominal y vómitos. Al examen físico está hidratado, con FC: 100x', FR: 15x', Tº: 38,7ºC; se aprecia faringe congestiva y eritematosa, amígdalas con exudado blanquecino y se palpan múltiples adenopatías dolorosas en la cara anterior del cuello. El examen pulmonar es normal. Se solicita test pack rápido para estreptococo A, que resulta positivo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Penicilina sódica
B) Cefadroxilo
C) Ciprofloxacino
D) Amoxicilina
E) Clindamicina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene clínica de amigdalitis bacteriana (fiebre alta, dolor intenso, exudado, adenopatías, ausencia de síntomas catarrales y edad clásica: total 5 puntos de la escala de Centor), por lo que no era necesario pedir el test pack, sino directamente tratar con amoxicilina, ampicilina o penicilina benzatina (duele, así que mejor tratamiento oral en niños).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 27 · 2.01.1.023 Faringoamigdalitis

Un niño de 2 años presenta tos de 3 días de evolución, asociado a odinofagia y fie- bre de 38 grados Celsius. Al examen físico presenta congestión y eritema de la faringe y las amígdalas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Ibuprofeno oral
B) Amoxicilina oral
C) Azitromicina oral
D) Aciclovir oral
E) Oseltamivir oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una simple infección respiratoria alta, que se trata de manera sintomática. Ac- tualmente se recomienda preferir el paracetamol y evitar los AINES en lo posible, en la edad pediátrica.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 134 · 2.01.1.023 Faringoamigdalitis

Un niño de 11 años presenta un cuadro de 10 días de evolución de congestión nasal y rinorrea mucopurulenta, asociada a fiebre de 38,5°C, tos y odinofagia. Al examen físico se observa descarga posterior purulenta y faringe congestiva y eritematosa. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Amoxicilina
B) Prednisona
C) Paracetamol
D) Clorfenamina
E) Clindamicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El diagnóstico es una amigdalitis aguda (se hace con la clínica). Por tener más de 7 días y estar muy sintomática, se puede presumir que es bacteriana, por lo que está indicado tratar con antibióticos, de elección, amoxicilina.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 42 · 2.01.1.023 Faringoamigdalitis

Una niña de 8 años, desde hace 6 meses presenta halitosis y odinofagia leve. Al examen físico se observan las amígdalas rosadas, con surcos profundos y en la amígdala derecha se observa secreción blanquecina, de aspecto caseoso, de 5 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

A) Mononucleosis infecciosa
B) Absceso peritonsilar
C) Amigdalitis bacteriana
D) Linfoma amigdalino
E) Tonsilolitiasis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene amigdalitos o tonsilolitos clásicos. Se observan y se enseña al paciente a retirárselos con un palillo.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 76 2.01.1.039 · Diarrea aguda y en vías de

Un niño de 18 meses, desde hace 24 horas, presenta fiebre hasta 38,7°C, asociado a episodios de vómitos alimentarios y seguido de diarrea acuosa abundante, con múltiples deposiciones. Al examen físico, se ve de buen aspecto, hidratado, tiene T°:37,2°C y frecuencia cardíaca normal. Su examen abdominal muestra abdomen blando, depresible e indoloro, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se realiza examen de deposiciones con tiras reactivas, que resultan positivos para rotavirus y Clostridium difficile (Clostridioides difficile). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Probar tolerancia y rehidratación por vía oral
B) Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
C) Iniciar metronidazol oral
D) Iniciar ceftriaxona endovenosa
E) Iniciar vancomicina endovenosa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Manejo de Diarrea Aguda con Portación Asintomática de Clostridium difficile: Un niño con diarrea aguda por rotavirus y portación asintomática de Clostridium difficile no requiere tratamiento para C. difficile. La portación asintomática en niños es frecuente y no suele complicarse. El metronidazol no ha demostrado mayor utilidad en estos casos. El manejo de este caso se centra en la diarrea por rotavirus con tolerancia oral y rehidratación oral..

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 74 2.01.1.039 · Diarrea aguda y en vías de

Niño de 2 años con gastroenteritis aguda de 24h de evolución, con vómitos y diarrea. Sin fiebre alta, sin sangre en deposiciones, mucosas hidratadas, llenado capilar normal, orina presente. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hospitalización y suero EV
B) Sales de rehidratación oral fraccionada en domicilio
C) Ayuno absoluto por 6 horas
D) Antibióticos orales empíricos
E) Antidiarreico (loperamida)

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Gastroenteritis sin deshidratación significativa: sales de rehidratación oral (SRO) fraccionada en domicilio es el manejo de primera línea. 5-10 mL cada 5 min al inicio. Loperamida contraindicada en menores de 2 años. Antibióticos solo si hay fiebre alta + sangre (disentería).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 146 2.01.1.039 · Diarrea aguda y en vías de

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días de evolución, que mejora tras rehidratación oral. Hemograma y electrolitos: normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la gastroenteritis?

A) Gastroenteritis bacteriana (Salmonella)
B) Gastroenteritis por Rotavirus
C) Infección urinaria
D) Enfermedad celíaca de debut
E) Fibrosis quística

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Gastroenteritis en lactante de 10 meses: Rotavirus es el agente más frecuente (diarrea acuosa, electrolitos normales, responde bien a rehidratación oral, curso benigno). La gastroenteritis bacteriana típicamente tiene fiebre alta y sangre. Rotavirus tiene vacuna desde los 2 meses.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 134 2.01.1.039 · Diarrea aguda y en vías de

Un niño de 7 meses de edad es hospitalizado por una bronquilitis aguda. Al quinto día de la hospitalización, presenta fiebre y diarrea acuosa abundante, de olor ácido, sin sangre, de cerca de 6 deposiciones líquidas al día. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Escherichia coli
B) Shiguella
C) Clostridium difficile
D) Rotavirus
E) Enterovirus

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las diarreas hospitalarias en niños suelen ser virales. Además una bronquiolitis aguda no tiene por qué recibir ATB, como para pensar en C. difficile

---

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 121 2.01.1.039 · Diarrea aguda y en vías de

Un niño de 11 meses de edad presenta un cuadro de fiebre, hasta 38,7 grados celsius, asociado a diarrea acuosa abundante, con deposiciones explosivas, ácidas, más irritabilidad importante.

A) Rotavirus
B) Enterovirus
C) Escherichia coli
D) Shigella
E) Adenovirus

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Rotavirus). El rotavirus es la causa más frecuente de diarrea acuosa febril en lactantes.. :::warning Los jugos, bebidas gaseosas y líquidos hiperosmolares están contraindicados: prolongan la diarrea. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 6 2.01.2.017 · Muerte súbita-ALTE, BRUE

Un niño de 24 meses es traído por episodios repetidos de llanto, apnea, seguidos de hipotonía y compromiso de conciencia, que luego se recuperan espontáneamente. En algunos de estos episodios, además, presentó movimientos clónicos, de corta duración. Los episodios se han presentado en relación a situaciones en las que ha llorado o se ha enojado mucho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar TAC de cerebro y electroencefalograma
B) Iniciar ácido valproico
C) Solicitar electroencefalograma
D) Iniciar carbamazepina
E) Indicar manejo conductual

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene apneas emotivas, que son ALTE de bajo riesgo. Orienta a eso la edad y la clara correlación con las emociones. Se observan y se educa. Los ALTE de alto riesgo, en cambio, son los que tienen menos de 6 meses, antecedentes de muerte súbita en la familia, alteraciones en el examen neurológico o cardiaco o la necesidad de reanimación.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 162 2.01.2.017 · Muerte súbita-ALTE, BRUE

Un niño de 24 meses ha presentado 3 episodios de llanto de breve duración, seguido de apena y luego pérdida de conciencia, recuperándose al poco tiempo. Al examen físico no tiene alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Instruir a los padres en reanimación cardiopulmonar
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Educar a los padres en el manejo de las emociones del niño
D) Solicitar electroencefalograma
E) Indicar monitor cardíaco

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Son apneas emotivas. Lo más indicado es la educación, ya que son de bajo riesgo. Dentro de los ALTE (evento que aparentemente amenaza la vida), las apneas emotivas son las de más bajo riesgo.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 143 2.01.2.017 · Muerte súbita-ALTE, BRUE

¿Cuál es la posición recomendada para que duerman los lactantes?

A) Prono
B) Decúbito lateral derecho
C) Supino
D) Decúbito lateral izquierdo
E) Alternar decúbito lateral derecho e izquierdo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Posición supina es la de menor riesgo para muerte súbita. Solo se recomiendan las otras posiciones en caso de reflujo, ya que puede aumentarlo.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 159 2.01.1.083 · Síndrome hipertónico

Un niño de 18 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, a las 32 semanas de edad gestacional, camina en punta de pies. Logró la marcha independiente hace un mes. Al examen físico, tiene aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, con hiperreflexia y presencia de signo de Babinski. El diagnóstico más probable es:

A) Estereotipia de la marcha
B) Retraso del desarrollo psicomotor
C) Diplejia espástica
D) Polineuropatía
E) Distrofia muscular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La caminata en punta de pies puede tener múltiples causas, siendo normal en menores de 3 años, pero también asociándose a trastornos del espectro autista (se `pensaría si tuviese otras estereotipias, alteraciones del lenguaje o de la interacción social) y se asocia asimismo a parálisis cerebral con espasticidad. La diplejía espástica es una variante de ello, en que se afectan las extremidades inferiores. Tiene buen pronóstico con un adecuado tratamiento multidisciplinario. La distrofia muscular suele tener un desarrollo normal, pero luego va perdiendo fuerza, especialmente en los grupos musculares grandes, que, por ejemplo, le dificulta ponerse de pie, por lo que suele hacerlo con el apoyo de las manos.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 144 2.01.1.083 · Síndrome hipertónico

Un niño de 16 meses, nacido a las 34 semanas de gestación, logra la posición sentada a los 10 meses y aún no camina. Además succiona y traga muy lento, y también presenta sialorrea. Su perímetro cefálico es de 45 cm, que corresponde a -2 DS y presenta espasticidad en sus 4 extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Parálisis cerebral
B) Hipotiroidismo congénito
C) Alteración enzimatico-metabólica
D) Microcefalia
E) Trastorno del desarrollo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Parálisis cerebral** (opción **A**). Cuadro clásico. :::tip El kernícterus (encefalopatía hiperbilirrubinémica) es una causa de parálisis cerebral completamente prevenible con el manejo adecuado de la ictericia neonatal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 133 2.01.1.083 · Síndrome hipertónico

Un niño de 24 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro, aún no logra la marcha sin apoyo, aunque recientemente logró ponerse de pie. La posición sentado comenzó a los 11 meses y actualmente tiene sialorrea, perímetro craneano en -2 DS y espasticidad de las cuatro extremidades, con reflejos osteotendíneos vívidos. El diagnóstico más probable es:

A) Parálisis cerebral
B) Diplejia espástica
C) Polineuropatía periférica
D) Microcefalia
E) Distrofia muscular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una parálisis cerebral de tipo espástica. En este caso, la prematurez probablemente fue la causa. No alcanza a tener una microcefalia (-3 DS), pero se sugiere daño cerebral. La diplejía espástica suele ser un tipo de parálisis cerebral, pero solo afecta las extremidades inferiores (no las 4). La polineuropatía periférica no tendría espasticidad (sino hipotonía), ni sialorrea, ni disminución del tamaño cefálico. La distrofia muscular solo tiene debilidad muscular progresiva, con hipertrofia de los músculos.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 140 2.01.1.083 · Síndrome hipertónico

Un lactante de 7 meses, en tratamiento con domperidona por reflujo gastroesofági- co, presenta desviación del cuello a la izquierda, asociado a llanto y movimientos irre- gulares de los ojos. Al examen físico presenta contractura de los músculos del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Crisis epiléptica focal
B) Distonía aguda por fármacos
C) Disquinesia aguda por fármacos
D) Síndrome de West
E) Infección por Clostridium tetani

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Distonía aguda por fármacos** (opción **B**). Es una tortícolis espasmódica clásica, que es un tipo de distonía.. :::tip El kernícterus (encefalopatía hiperbilirrubinémica) es una causa de parálisis cerebral completamente prevenible con el manejo adecuado de la ictericia neonatal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 18 2.01.1.127 · TORCH

RN con microcefalia, calcificaciones periventriculares y coriorretinitis. Madre con serología IgG positiva para CMV y IgM positiva. ¿Cuál es el agente causante de la infección congénita?

A) Citomegalovirus (CMV)
B) Toxoplasma gondii
C) Virus herpes simplex tipo 2
D) Treponema pallidum
E) Virus de rubéola

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
CMV congénito es la infección congénita viral más frecuente. Calcificaciones periventriculares (vs parenquimatosas en toxoplasma) + microcefalia + coriorretinitis = TORCH por CMV.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 96 2.01.1.127 · TORCH

Un recién nacido de 38 semanas, presenta hipotonía, dificultad a la succión y circunferencia craneana 26 cm. Al examen tiene ausencia del rojo pupilar bilateral y ambas pupilas se observan de aspecto blanquecino. Además, se ausculta un soplo sistólico eyectivo III/VI, paraesternal. ¿Cuál es el agente más probable?

A) Virus rubéola
B) Parvovirus B12
C) Citomegalovirus
D) Toxoplasma gondii
E) Virus herpes simplex

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La rubéola congénita se caracteriza por todo lo que tiene el caso: cardiopatía congénita, catarata congénita, microcefalia y, además, suele ser pequeño para la edad gestacional (PEG). El CMV y el toxoplasma suelen presentar microcefalia, calcificaciones cerebrales, hipotonía y ser PEG. El PVB19 en el embarazo produce abortos o hídrops fetal.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 77 2.01.1.127 · TORCH

Un recién nacido de término, pequeño para la edad gestacional, presenta un cuadro de ictericia y alteración de la termorregulación. Al examen físico tiene un síndrome purpúrico y se palpa hepatoesplenomegalia. Se solicitan exámenes, en los que destaca trombocitopenia. ¿Cuál es el agente más probable?

A) Virus rubéola
B) Citomegalovirus
C) Virus herpes simplex
D) Treponema pallidum
E) Estreptococo betahemolítico grupo B

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un TORCH clásico (pequeño para la edad gestacional), cuya causa más frecuente es el CMV. La sepsis (por SGB) puede tener un cuadro similar, pero le sobra lo pequeño para la edad gestacional.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 46 2.01.1.127 · TORCH

Recién nacido de término, con peso bajo para edad gestacional, tiene perímetro cefálico menor a percentil 3 para la edad gestacional y evoluciona después de nacer con ictericia progresiva, más hepatomegalia. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Citomegalovirus
B) Virus papiloma humano
C) VIH
D) Virus Zika
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un TORCH clásico por CMV (microcefalia, calcificaciones cerebrales, ictericia y hepatoesplenomeglalia). En Chile no hay Zika. El TORCH por toxoplasma es casi igual al del CMV, pero es más infrecuente y, además, puede cursar con hidrocefalia.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 145 2.01.1.127 · TORCH

Un recién nacido presenta hepatoesplenomegalia e ictericia. Tiene además calcificaciones cerebrales y microcefalia. Evoluciona con coriorretinitis y aumento progresivo del perímetro craneano. El diagnóstico más probable es:

A) Infección por VIH
B) Infección por Streptococcus agalactiae
C) Rubeóla congénita
D) Toxoplasmosis congénita
E) Sífilis congénita

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cuadro clásico. Sin embargo la pregunta es muy difícil y claramente no es de médico general, ya que basta decir que tiene un TORCH. Esa clínica además es muy probable de un citomegalovirus. La rubeolo porduce microcefalia, cardiopatía y cataratas. La sífilis produce exantema, perforación del tabique nasal, deformaciones múltiples.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 68 2.01.1.127 · TORCH

Usted a8ende a un recién nacido cuya madre inició con síntomas de varicela dos días antes del parto. El niño se encuentra en buenas condiciones, con signos vitales normales, y no 8ene lesiones cutáneas ni otras alteraciones en el examen Fsico realizado de forma minuciosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de este niño?

A) Indicar aciclovir por vía oral
B) Solicitar PCR para virus varicela-zóster en sangre
C) Indicar lactancia materna desde banco de leche
D) Mantener en observación e iniciar medidas únicamente si presenta lesiones cutáneas
E) Administrar inmunoglobulina hiperinmune an2varicela

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene alto riesgo de varicela neonatal grave (exantema materno que inicia entre 5 días antes y 2 días después del parto). Se trata con IgG específica antivaricela. Si desarrolla síntomas, además, se da aciclovir endovenoso. Si no estuviera disponible la IgG antivaricela, también se da aciclovir EV.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 155 · 2.01.1.046 · Reflujo gastroesofágico y

Un niño de 28 días presenta vómitos después de comer, que iniciaron hace una semana y que han aumentado en frecuencia e intensidad. La madre refiere que llora después de comer y vomitar y se objetiva que no ha incrementado bien de peso en el último tiempo, observándose algo enflaquecido. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
B) Ecografía abdominal
C) Endoscopía digestiva alta con biopsia duodenal
D) Colonoscopía con biopsia de la pared intestinal
E) Radiografía simple toracoabdominal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Ecografía abdominal). Tiene una estenosis hipertrófica del píloro, que se estudia con ecografía abdominal.. Tratamiento: 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 147 · 2.01.1.046 · Reflujo gastroesofágico y

Un lactante está en tratamiento por reflujo gastroesofágico con medicamento en gotas. Presenta un cuadro de trismus, nistagmus, más hiperextensión del cuello. ¿Qué fármaco es más probable que esté recibiendo?

A) Omeprazol
B) Cisaprida
C) Metoclopramidad
D) Domperidona
E) Difenhidramina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto metoclopramida, como domperidona pueden producir síntomas extrapiramidales, pero son más frecuentes en la metoclopramida. La cisaprida se retiró del mercado, pero por producir arritmias.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 76 · 2.01.1.046 · Reflujo gastroesofágico y

Un recién niño de 28 días de vida presenta vómitos, desde hace una semana, que son explosivos, generalmente postprandiales. Además, ha detenido su crecimiento y se encuentra más irritable de lo normal, aparentemente por hambre. Al examen físico, está en buenas condiciones generales, se observa hidratado y bien perfundido, sin alteraciones en el examen segmentario. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir con el estudio de este paciente?

A) Ecografía abdominal
B) Intento de instalación de sonda nasogástrica
C) Radiografía toracoabdominal
D) Tomografía axial computada de abdomen
E) Endoscopía digestiva alta

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ecografía abdominal** (opción **A**). Reflujo fisiológico: regurgitaciones sin complicaciones <1 año; manejo: tranquilizar + espesar tomas De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 137 · 2.01.1.046 · Reflujo gastroesofágico y

Un lactante de 2 meses presenta vómitos frecuentes, que iniciaron hace dos semanas y han ido en aumento, siendo abundantes y ocurriendo en especial después de tomar leche. En su examen Fsico se ve de buen aspecto y toma leche ávidamente, tras lo cual vuelve a vomitar. Se solicitan exámenes entre los que destaca glicemia 90 mg/dL, natremia 140 mEq/L, cloremia 102 mEq/L y potasemia 4,2 mEq/L. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Hiperplasia suprarrenal congénita
B) Enterocoli2s necro2zante
C) Atresia duodenal
D) Enfermedad de Hirschsprung
E) Estenosis pilórica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una estenosis hipertrófica pilórica clásica, que suele iniciar entre las 2 y 6 semanas de edad. Se diagnostica con ecografía abdominal y se trata con cirugía (pilorotomía). Los electrolitos normales son compaGbles con ella. La HSRC, en cambio Gende a la hipoglicemia, hiperkalemia e hiponatremia. La enterocoliGs necroGzante y la atresia duodenal producen síntomas en los primeros días de vida.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 79 · 2.01.1.046 · Reflujo gastroesofágico y

Un lactante de 1 mes comienza con cuadros de vómitos explosivos, después de cada toma de leche. La madre, además, nota que está irritable y hambriento. Al examen físico, se observa leve ictericia de piel y escleras, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan sodio plasmático: 140 mEq/l, potasio plasmático: 3,2 mEq/L, pH plasmático: 7,47. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Radiografía abdominal
B) Colonoscopía
C) 17-hidroxi-progesterona
D) Ecografía abdominal
E) TAC de glándulas suprarrenales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Estenosis Hipertrófica del Píloro: La sospecha clínica es una estenosis hipertrófica del píloro, que se estudia con ecografía abdominal y se trata con la piloromiotomía de Ramstedt. Los exámenes son compatibles con vómitos que causan pérdida de ácido y potasio, lo que lleva a una alcalosis metabólica e hipopotasemia. Si los exámenes hubieran sugerido insuficiencia suprarrenal (hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica), la sospecha habría sido hiperplasia suprarrenal, que se estudia con la 17-hidroxiprogesterona.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 72 · 2.01.1.046 · Reflujo gastroesofágico y

Lactante con emesis pero que “no tenía relación con la alimentación” pero tenía oliva pilorica y otros signos sugerentes

A) Alergia a proteína de leche
B) estenosis hipertrofica piloro
C) Atresia pilórica
D) Invaginación intestinal
E) Reflujo gastroesofágico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Alergia a proteína de leche). estenosis hipertrofica piloro. Tratamiento: 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (estenosis hipertrofica piloro, Atresia pilórica) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 72 2.01.1.020 · Bronquiolitis

Un lactante de 5 meses presenta un cuadro de tos y coriza, asociada a fiebre hasta 38,5°C. Al día siguiente evoluciona con dificultad respiratoria, taquipnea, retracción subcostal y subcostal. Al examen físico tiene FR: 70x', uso de musculatura accesoria, sibilancias inspiratorias y espiratorias difusas e intensas, más cianosis perioral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Virus respiratorio sincicial
B) Bordetella pertusis
C) Virus influenza
D) Virus parainfluenza
E) Neumococo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Virus respiratorio sincicial). Es una bronquiolitis clásica, por VRS.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 158 2.01.1.020 · Bronquiolitis

Un lactante de 8 meses presenta fiebre y rinorrea de 48 horas de evolución, con dificultad respiratoria en las últimas horas. Al examen físico presenta retracción subcostal e intercostal moderada, frecuencia cardíaca: 120x', frecuencia respiratoria: 35x', saturación de oxígeno del 93%s. En el examen pulmonar se auscultan sibilancias y crépitos bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Bronquiolitis
B) Asma del lactante
C) Neumonía multifocal
D) Neumonía atípica
E) Cardiopatía congénita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Bronquiolitis: Es un caso clásico de bronquiolitis, causada generalmente por el virus respiratorio sincitial (VRS) y que se define como el primer episodio de síndrome bronquial obstructivo en un lactante.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 148 2.01.1.020 · Bronquiolitis

Un lactante de 5 meses de edad es llevado a urgencias, por presentar un cuadro de obstrucción bronquial. Al examen físico presenta taquipnea importante, satura 90%, tiene retracción intercostal, cianosis perioral y sibilancias bilaterales intensas. ¿Cuál es la primera medida que se debe tomar?

A) Nebulizaciones con salbutamol
B) Nebulizaciones por
C) Dar corticoides orales
D) Dar oxígeno por mascarilla
E) Administrar corticoides endovenosos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ante una hipoxia, en un trastorno V/Q, lo más urgente siempre es el oxígeno. Además hoy está demostrado que el oxígeno es lo único realmente util en la bronquiolitis y que no sirven ni corticoides ni broncodilatadores

---

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 166 2.01.2.011 · Hipertensión endocraneana

Un niño de 4 años presenta cefalea de 1 mes de evolución, que es mayor en las mañanas y se asocia a diplopía. Además, ha presentado náuseas y vómitos alimentarios en el último tiempo, que han aumentado su frecuencia. ¿Cuál es la causa más probable de su cefalea?

A) Migraña de presentación atípica
B) Cefalea tensional
C) Jaqueca clásica
D) Vicio de refracción
E) Hipertensión endocraneana

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

No queda claro la causa precisa de sus síntomas (tumor cerebral, meningitis tuberculosa, pseudotumor cerebral), pero sí tiene un síndrome de HTEC clásico, con 1. la cefalea de predominio matinal, 2. las náuseas y vómitos y 3. solo le falta el edema de papila. La migraña y la cefalea tensional suelen aumentar en las tardes y no en las mañanas.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 149 2.01.2.011 · Hipertensión endocraneana

Un niño de 6 años entra al colegio hace 4 semanas. Hace 3 semanas inicia cefalea progresiva, más intensa en la mañana. Se agregan náuseas y vómitos escasos y diplopía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno por ansiedad de separación
C) Jaqueca clásica
D) Hipertensión endocraneana
E) Vicio de refracción

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Hipertensión endocraneana** (opción **D**). El predominio matinal, los vómitos y la diplopia orientan a hipertensión endocraneana.. Implantación del embarazo fuera del útero. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 150 2.01.1.138 · Maltrato infantil

Un lactante de 6 meses es traído por la madre, porque presenta epistaxis. La madre, de 17 años, refiere que se cayó de la cama. Al examen está poco reactivo y presenta múltiples equimosis, algunas de color morado y otras de color verde. Además tiene dos fracturas costales posteriores. Su TAC de cerebro muestra un hematoma subdural. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

A) PTH y calcio
B) Tiempos de coagulación
C) Exáenes para descartar osteogénesis imperfecta
D) Fondo de ojo
E) Ecografía abdominal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Sospechar maltrato infantil. El fondo de ojo muestra las microhemorragias en el síndrome del niño sacudido (Shaking baby). Pero en realidad el diagnóstico ya está hecho y lo más urgente es operar el hematoma subdural. Pregunta mala.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 135 2.01.1.042 · Fibrosis quística

Niño de 8 meses que sufre desde hace 6 meses diarrea pastosa, abundante. Tiene también antecedente de episodios bronquiales obstructivos y 4 cuadros de infecciones respiratorias, que han requerido de hospitalización. Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A) Enfermedad celiaca
B) Enteropatía perdedora de proteínas
C) Enfermedad de cilio inmóvil
D) Fibrosis quística
E) Alergia a la proteína de la leche de vaca

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto por las infecciones respiratorias, como por la malabsorción es una fibrosis quística. Las demás opciones producen solo síntomas digestivos (A, B y E) o solo neumonías (C).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 56 2.01.1.042 · Fibrosis quística

Un lactante de 7 meses, con antecedente de haber sido hospitalizado en varias opor- tunidades por cuadros respiratorios febriles, presenta diarrea de algunos meses de evo- lución, asociada a esteatorrea y mal incremento ponderal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad celíaca
B) Inmunodeficiencia primaria
C) Fibrosis quística
D) Alergia a la proteína de la leche de vaca
E) Giardiasis intestinal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La FQ suele producir neumonías bacterias (S. aureus y P. aureginosa) y un síndro- me de malabsorción.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 151 2.01.1.042 · Fibrosis quística

Un niño de 8 meses de edad ha presentado 5 cuadros de bronquitis obstructiva y además ha presentado diarrea acuosa de 2 meses de evolución. No ha subido de peso en dicho periodo. ¿Qué examen debe realizarse?

A) Anticuerpos antitransglutaminasa
B) Niveles plasmáticos de IgA
C) Test del sudor
D) Elisa VIH
E) Colonoscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Test del sudor). Sospechar una fibrosis quística. Se diagnostica con test del sudor. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 6 2.01.1.042 · Fibrosis quística

Lactante de 4 meses con infecciones respiratorias a repetición, deposiciones grasas malolientes y retraso pondoestatural. La madre refiere que el sudor del niño "sabe salado". ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección?

A) Broncoscopía
B) Test del sudor (electrolitos en sudor)
C) Test de metacolina
D) TAC de tórax de alta resolución
E) Espirometría

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Fibrosis quística: infecciones respiratorias recurrentes + esteatorrea + sudor salado (elevado NaCl). Diagnóstico: test del sudor (cloro en sudor ≥60 mEq/L = positivo). Es el gold standard diagnóstico en pediatría.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 114 2.01.1.042 · Fibrosis quística

Un lactante de 26 días presenta deposiciones abundantes y frecuentes con visualización de gotas de grasa. Además, sus padres comentan que al besarla su piel 8ene un sabor salado. El resto del examen Fsico no aporta mayor información. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar la sospecha diagnós8ca?

A) Colonoscopía con biopsia por succión
B) Ecogra:a abdominal
C) Endoscopía diges2va alta con biopsia de duodeno
D) Niveles plasmá2cos de 17-hidroxiprogesterona
E) Determinación de electrolitos en el sudor

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una fibrosis quística, cuya clínica se caracteriza por infecciones respiratorias, malabsorción intestinal y puede tener piel salada. El diagnóstico se hace con el test del sudor, que muestra aumento del cloro en sudor. - Cloro > 60 mEq/L: confirma diagnóstico. - Cloro 30-60 mEq/L: sospecha intermedia. Se repite examen y se estudia genéticamente. - Cloro < 30 mEq/L: descarta fibrosis quística.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 156 2.01.1.042 · Fibrosis quística

Una niña de 30 días de vida con mal incremento ponderal presenta deposiciones amarillas, abundantes y oleosas. Los padres refieren que su piel tiene un sabor salado. ¿Cuál es el examen más adecuado para realizar el diagnóstico?

A) Ecografía abdominal
B) Colonoscopía
C) Anticuerpos anti-transglutaminasa y endoscopía digestiva alta
D) Electrolitos en sudor
E) Hemograma y pruebas de función renal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Electrolitos en sudor** (opción **D**). Se sospecha una fibrosis quística, que se estudia con el test del sudor, que mide cloro en el sudor.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 125 2.01.1.042 · Fibrosis quística

Lactante con bronquitis a repetición, esteatorrea y anemia ferropénica:

A) Fibrosis Quística
B) Enfermedad celiaca
C) Inmunodeficiencia primaria
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Fibrosis Quística). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Enfermedad celiaca, Inmunodeficiencia primaria) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 154 2.01.1.054 · Soplos

Un niño de 13 años acude a control médico, por una infección respiratoria alta. En su examen físico se ausculta un soplo paraesternal izquierdo, sistólico, de intensidad II/VI, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Soplo inocente
B) Ductus arterioso persistente
C) Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
D) Estenosis aórtica
E) Coartación aórtica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Soplo inocente** (opción **A**). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 79 2.01.1.054 · Soplos

Un niño de 4 meses acude a control de niño sano. La madre refiere que se cansa al mamar leche, por lo que no ha tenido un adecuado incremento ponderal. Al examen físico, se ausculta soplo holosistólico en toda la zona precordial, de intensidad III-IV sobre VI que se irradia hacia la espalda. En el examen pulmonar se auscultan crepitaciones bilaterales, escasas, sin otros ruidos. Además, en el examen abdominal se palpa el borde del hígado a 3 cm del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Comunicación interauricular
B) Comunicación interventricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Canal aurículo-ventricular
E) Soplo funcional

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Soplo funcional** (opción **E**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 3 2.01.1.054 · Soplos

Un niño de 8 meses es traído, por su madre, al control de niño sano. En el examen físico se ausculta un segundo ruido desdoblado, asociado a un soplo sistólico eyectivo. El diagnóstico más probable es:

A) Comunicación auricular
B) Comunicación interventricular
C) Ductus arterioso persistente
D) Estenosis aórtica
E) Coartación aórtica supravalvular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Comunicación auricular** (opción **A**). Es una CIA clásica (ver resumen de semiología cardíaca).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 79 2.01.1.107 · Dermatitis atópica

Una niña de 4 años presenta lesiones cutáneas recurrentes de 2 años de evolución, caracterizadas por pápulas pruriginosas que aparecen en los antebrazos y fosas cubitales, así como en las piernas, fosas poplíteas, cara y cuello. Su madre comenta que pasa por periodos de exacerbación de las lesiones y otros en que son mucho menos intensas. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Derma22s alérgica
B) Ur2caria
C) Derma22s atópica
D) Escabiosis
E) Derma22s seborreica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Derma22s atópica). Es una dermaGGs atópica clásica: lesiones crónico recidivantes, en zonas flexoras, más mejillas.. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel con fuerte componente genético y atópico, caracterizada por piel seca, eccema pruriginoso y períodos de exacerbación y remisión. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 12 2.01.1.107 · Dermatitis atópica

Un niño de 20 días de edad, presenta lesiones eritematosas, con descamación en la cabeza y la zona interciliar, con descamación amarilla, de aspecto oleoso. Se ve de buen aspecto y ha subido de peso. La indicación más adecuada es:

A) Administrar fórmula, con proteína hidrolizada, como alimentación
B) Crema de betametasona tópica
C) Crema de clotrimazol tópico
D) Vaselina topica
E) Antibióticos tópicos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo más correcto es simplemente observar evolución, porque es una dermatitis seborreica del lactante. Sin embargo, también se le puede aplicar vaselina o aceite mineral, para ayudar a remover la descamación. En los adultos, por ser por un hongo (Pitirosporum ovale), sí se suelen usar los antimicóticos tópicos, e incluso los cortcoides tópicos como segunda línea, pero en los niños, se prefiere o no hacer nada o aplicar vaselina.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 17 · 2.01.3.018 · Supervisión de salud- lact

Un lactante de 11 meses acude a control de niño sano, constatándose que no tiene aún ningún diente. El resto de su examen físico, así como su desarrollo psicomotor es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar al odontopediatra
B) Solicitar radiografía panorámica dentaria
C) Solicitar TSH plasmática
D) Solicitar niveles plasmáticos de vitamina D
E) Observar evolución y controlar en 2 meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La erupción dentaria puede observarse hasta los 15 meses. A esa edad recién se piden las radiografías. Nota: la típica pregunta de pediatría: "un niño tiene una alteración rara que nunca has escuchado en tu vida, pero todo lo demás está estrictamente normal. La conducta es:"... ¡¡¡Observar!!!

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 120 · 2.01.1.048 · Síndrome malabsorción

Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además, presenta deposiciones frecuentes y disgregadas, con tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Anticuerpos IgA antiendomisio
B) Cuantificación de inmunoglobulinas
C) Test del sudor
D) Colonoscopía
E) 17 – OH – progesterona

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Se sospecha una enfermedad celíaca, que se estudia con anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomisio, más una endoscopía digestiva alta, con biopsia duodenal.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 113 · 2.01.1.048 · Síndrome malabsorción

Una niña de 18 meses de edad presenta un cuadro de diarrea de 3 semanas de evolución, abundante, que ha empeorado en el último tiempo y se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios. Al examen físico está deshidratada y decaída, sin compromiso hemodinámico evidente y su examen abdominal muestra abdomen sensible, con ruidos hidroaéreos conservados. Se solicitan exámenes, que muestran Na+: 130 mEq/L, K+: 3,4 mEq/L, glicemia: 65 mg/dl, creatinina: 1,2 mg/dl, ferritina: 10 ug/L y hematocrito: 29%, VCM: 70 fl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Diarrea por rotavirus
B) Crisis celíaca
C) Hiperplasia suprarrenal congénita
D) Diarrea crónica inespecífica
E) Giardiasis intestinal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La anemia ferropénica (ferritina menor a 15 y VCM bajo) sugiere enfermedad celíaca. La HSRC cursa con compromiso hemodinámico, hiperkalemia, hipoglicemia e hiponatremia.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 160 · 2.01.1.048 · Síndrome malabsorción

Una niña de 1 año y 10 meses presenta diarrea de dos meses de evolución, con mal incremento ponderal. Hace una semana empeora la diarrea y se agregan vómitos y malestar general. Al examen físico tiene edema de extremidades inferiores y palidez y su abdomen se palpa blando, sensible, sin irritación peritoneal. Se piden exámenes en los que destacan Na+: 132 mEq/L, K+: 2,8 mEq/L, glicemia: 66 mg/dl, albuminemia: 2,1 g/dl y hematocrito: 30%. El diagnóstico más probable es:

A) Parasitosis intestinal
B) Fibrosis quística
C) Enteropatía perdedora de proteínas
D) Diarrea viral
E) Crisis celiaca

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una crisis celíaca clásica: historia compatible con enfermedad celíaca previa, que se descompensa. En los exámenes tiene signos carenciales: hipoalbuminemia, hipokalemia y ferropenia.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 132 · 2.01.1.048 · Síndrome malabsorción

Una niña de 4 años, celiaca desde hace 2 años, en tratamiento con dieta, desde el diagnóstico. En el último tiempo ha presentado diarrea y metorismo, por lo que los padres sospechan que está incumpliendo la dieta en el jardín infantil. ¿Cuál es el examen inicial para confirmar la sospecha diagnóstica?

A) Endoscopía digestiva alta, con biopsia de duodeno
B) Anticuerpos antigliadina clásicos
C) Anticuerpos antireticulina
D) Anticuerpos antiendomisio
E) Prueba de la D-xilosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomisio son de elección tanto para el diagnóstico, como para confirmar la adherencia a la dieta (negativizan luego de varios meses sin consumo de gluten).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 141 · 2.01.1.048 · Síndrome malabsorción

Una niña de 13 meses de edad, desde hace 4 meses ha detenido su crecimiento. Además presenta diarrea, con deposiciones pastosas y tendencia al meteorismo. En sus exámenes destaca anemia ferropénica. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Anticuerpos IgA antiendomisio
B) Recuento total de inmunoglobulinas
C) Test del sudor
D) Radiografía de mano
E) 17 – OH – progesterona

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto por la edad, como por la clínica, parecía una enfermedad celíaca. No tenía síntomas respiratorios, como para sospechar una FQ.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 19 2.01.1.048 · Síndrome malabsorción

Un niño de 2 años, presenta deposiciones abundantes y pastosas, de 1 año de evolución. Además ha subido poco de peso en ese tiempo, teniendo actualmente un índice peso/talla de -1 DS y peso/edad de -2 DS. No ha tenido cuadros febriles. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad celíaca
B) Fibrosis quística
C) Diarrea crónica inespecífica
D) Intolerancia a la lactosa
E) Alergia a la proteína de vaca

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una enfermedad celiaca clásica. Aunque no cumple criterios de talla baja (talla/edad < -2) ni de desnutrición (peso/talla >/= -2), igual es alarmante que no haya subido de peso, como es esperable. Si hubiese tenido sintomatología respiratoria, sería fibrosis quística.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 22 2.01.1.069 · Síndrome nefrótico

Un niño de 4 años, presenta un cuadro de 10 días de evolución de edema bipalpebral, a lo que se ha agregado, en los últimos dos días, oliguria y orinas espumosas. Al examen físico presenta presión arterial 102/62 mmHg, FC: 80x', edema facial y de extremidades inferiores. En sus exámenes destaca examen de orina con proteínas ++, creatininemia 0,9 mg/dl y BUN: 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome nefrótico
B) Glomerulonefritis aguda
C) Insuficiencia renal crónica
D) Síndrome hemolítico urémico
E) Nefritis intersticial

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un síndrome nefrótico clásico (orina espumosa, edema y proteinuria), aunque le faltan los exámenes confirmatorios (proteinuria cuantitativa o índice proteinuria / creatininuria, albumnemia y perfil lipídico). No hay hematuria dismórfica, así que no puede ser una glomerulonefritis. No tiene insuficiencia renal, así que no puede ser ninguna de las otras opciones.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 60 2.01.1.069 · Síndrome nefrótico

Un lactante de 2 años es traído por presentar aumento de volumen facial y edema de las extremidades inferiores. La madre refiere, además, que presenta orinas espumosas desde hace una semana. Al examen Fsico se observa edema blando de las extremidades inferiores y de la cara. Su frecuencia cardíaca es 80 la8dos por minuto y su presión arterial es 87/54 mmHg. Se solicitan exámenes, destacando examen de orina con 2 glóbulos rojos por campo y proteinuria: 4+, crea8nina: 0,7 mg/dL, BUN: 12 mg/dL, albuminemia: 2,7 g/dL, colesterol total: 310 mg/dL y triglicéridos plasmá8cos: 560 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar prednisona vía oral en alta dosis
B) Derivar para biopsia renal
C) Iniciar diuré2cos
D) Indicar dieta baja en sodio y en potasio
E) Realizar hemodiálisis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un síndrome nefrótico puro, por lo que lo más probable es que sea una nefrosis lipoidea o nefropaVa a cambios mínimos, que se trata con corticoides orales en alta dosis. Si no responde o si hubiese sido impuro (falla renal, HTA, hematuria), se realizaría biopsia renal. Si bien lo más frecuente es que la glomerulopaVa a cambios mínimos inicie entre los 5 y 10 años, a los 2 años es poco probable que sea un síndrome nefrótico congénito. En cambio, si tuviese menos de 1 año, se manejaría como síndrome nefrótico congénito, que suele presentarse en los primeros 3 meses de vida, es genético, se estudia con pruebas genéticas y biopsia renal y se trata con trasplante renal.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 91 2.01.1.055 · Alergias

Lactante de 2 meses con diarrea, vómitos y dermatitis perioral y perianal tras introducción de fórmula láctea. Test de parche positivo para proteína de leche de vaca. ¿Cuál es el manejo?

A) Cambiar a fórmula extensamente hidrolizada o elemental
B) Continuar fórmula habitual y agregar antihistamínico
C) Hospitalizar para estudio endoscópico
D) Iniciar corticoides orales
E) Cambiar a leche de soja

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Alergia a proteína de leche de vaca (APLV): tratamiento = fórmula extensamente hidrolizada (FEH). Si se usa leche materna, la madre elimina lácteos. Soja no recomendada bajo 6 meses (cross-reactividad).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 34 2.01.1.055 · Alergias

Un niño de 4 años presenta aparición de ronchas evanescentes en el tronco y extremidades, desde hace 4 días. Además, desde hace algunos días presentaba congestión nasal, con coriza y estornudos. Al examen físico se observan habones en el tórax y dermatografismo en las extremidades inferiores. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar corticoides orales
B) Solicitar prick test
C) Indicar antihistamínicos orales
D) Solicitar IgE sérica total
E) Solicitar test de parches

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Indicar antihistamínicos orales** (opción **C**). Es una urticaria aguda, que se trata con antihistamínicos.. La terapia biologica son anticuerpos monoclonales inyectables, habitualmente mensuales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 178 2.01.1.055 · Alergias

Niño con rash urticarial, edema de labios, taquicardia y sensibilidad abdominal. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Adrenalina 0,01 mg/kg IM
B) Difenhidramina EV
C) Hidrocortisona 5 mg/kg EV
D) Clorfeniramina oral
E) Salbutamol inhalado

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Adrenalina 0,01 mg/kg IM** (opción **A**). Adrenalina 0,01 mg/kg IM. La terapia biologica son anticuerpos monoclonales inyectables, habitualmente mensuales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 55 2.01.1.055 · Alergias

Un recién nacido de 28 días, presenta, desde hace 7 días, deposiciones frecuentes, semiformadas, con mucosidad y algunas estrías de sangre. Ha subido bien de peso, está con alimentación mixta y su examen físico no tiene alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Intolerancia a la lactosa
B) Alergia a la proteína de la leche de vaca
C) Infección por rotavirus
D) Sangre deglutida del pezón materno
E) Fisura anal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ya sé que en clases les dije que era una fisura anal, pero la verdad es que cambié de opinión. La forma en que está redactada es difícil, ya que "deposiciones semiformadas" sí orientan a fisura. Sin embargo, la mucosidad (aunque puede ser normal) sugiere algo más la APLV y, además, que hagan énfasis en que está con alimentación mixta y que tiene deposiciones frecuentes, hace que sea mejor marcar la B. También sugiere que sea la B el resto de las opciones, que muestran que las redactó el pediatra general o digestivo y no el cirujano pediátrico. Sea como sea, lo importante es saber que, aunque uno se sepa la materia, siempre tendrá preguntas malas en el Eunacom y por ello es tan importante estudiar bien, hasta lograr un nivel de conocimiento en el que no importe tener algunas malas por leer mal o porque pensaron mal en el minuto de tiempo que tienen.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 84 2.01.1.055 · Alergias

Alérgico a mariscos crudos con 2 reacciones anafilácticas previas en los últimos 3 meses, que indicarle a la mama:

A) adrenalina SOS
B) Corticoides VO en siguiente episodio
C) Antihistamínicos de uso permanente
D) Observar y consultar si le pasa algo al comer
E) Comer mariscos cocidos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (adrenalina SOS). Esta clase introduce la terapia biologica con anticuerpos monoclonales en el manejo de alergias graves y refractarias al tratamiento convencional. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 152 2.01.1.055 · Alergias

Una niña de 6 años, desde hace dos horas presenta edema de los labios, más aparición de múltiples lesiones habonosas y pseudopapulares generalizadas. Además, presenta dolor abdominal persistente y náuseas. ¿Cuál es el fármaco que debe recibir inmediatamente?

A) Prednisona
B) Clorfenamina
C) Gluconato de calcio
D) SalbutamolSínt
E) Adrenalina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Adrenalina** (opción **E**). La terapia biologica son anticuerpos monoclonales inyectables, habitualmente mensuales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 99 2.01.1.055 · Alergias

Una niña de 3 años, en tratamiento con amoxicilina, desde hace 9 días, por una amigdalitis, evoluciona con fiebre y aparición de un exantema morbiliforme generalizado, con lesiones en diana y úlceras en las mucosas oral, rectal y vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Urticaria
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Síndrome de Steven Johnson
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las lesiones en diana y la gran afectación de mucosas hace que el diagnóstico sea un SSJ. La mononucleosis sí tendría el exantema morbilifrome, pero sin afectación rectal ni vaginal y habría aparecido al inicio del uso de la amoxicilina.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 23 2.01.1.055 · Alergias

Una niña de 5 años, en tratamiento con amoxicilina por una amigdalitis, evoluciona al séptimo día con fiebre y lesiones cutáneas generalizadas. Al examen físico se aprecian lesiones en tiro al blanco, asociadas a úlceras en las mucosas oral, rectal y vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Urticaria aguda
B) Gingivoestomatitis herpética
C) Síndrome de Steven Johnson
D) Escarlatina
E) Mononucleosis infecciosa

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un síndrome de Steven Johnson clásico (rash pápulovesicular, con compromiso importante de mucosas, sin Nikolski). Las lesiones en tiro al blanco también se ven en el eritema multiforme menor, pero no suele afectar las mucosas.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 109 2.01.1.037 · Tumores sólidos

Un niño de 7 años presenta orinas oscuras, desde hace 5 días, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa una masa abdominal en el flanco derecho de 10 cm de diámetro. Se solicitan exámenes entre los que destacan bilirrubina: 1,0 mg/dl, creatinina: 1,1 mg/dl, sedimento de orina con 30-40 glóbulos rojos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Riñón poliquístico
B) Neuroblastoma
C) Hapatoblastoma
D) Tumor de Wilms
E) Linfoma

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La asociación de hematuria y masa obliga a descartar un tumor de Wilms o nefroblastoma, el cáncer renal más frecuente en niños (en adultos lo más frecuente es el cáncer de células renales).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 77 2.01.1.037 · Tumores sólidos

Un niño de 4 años, presenta orinas oscuras, desde hace 7 días. Al examen físico se palpa una masa abdominal sólida, en relación al flanco izquierdo, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes de orina, que muestran sedimento con 2 leucocitos por campo, 35 eritrocitos por campo, sin bacterias ni cristales. El urocultivo resulta negativo. Su hemograma es normal y su creatinina es 0,7 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Riñón poliquístico
B) Neuroblastoma
C) Hepatoblastoma
D) Tumor de Wilms
E) Estenosis pielocalicilar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Hepatoblastoma** (opción **C**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Riñón poliquístico, Neuroblastoma) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 32 2.01.1.037 · Tumores sólidos

Niño de 4 años con orinas oscuras, masa palpable en flanco izquierdo y hematuria sin leucocituria. ¿El diagnóstico más probable es?

A) Tumor de Wilms
B) Neuroblastoma
C) Quiste renal simple
D) Hidronefrosis severa
E) Linfoma retroperitoneal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Tumor de Wilms** (opción **A**). Tumor de Wilms. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 27 2.01.1.037 · Tumores sólidos

Niño con estrabismo fijo asociado a pérdida del rojo pupilar. El diagnóstico más probable es:

A) Retinoblastoma
B) Catarata congénita
C) Glaucoma congénito
D) Hemangioma retinal
E) Uveítis anterior

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Retinoblastoma** (opción **A**). Retinoblastoma. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 34 2.01.1.037 · Tumores sólidos

Un niño de 2 años presenta estrabismo divergente, con desviación del ojo derecho hacia temporal, que apareció hace pocos meses y que ha ido progresando. Al examen físico, además se constata ausencia del rojo pupilar de ese ojo. El diagnóstico más probable es:

A) Glaucoma congénito
B) Retinoblastoma
C) Catarata congénita
D) Leucoma
E) Estrabismo esencial

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es la clínica clásica del retinoblastoma (leucocoria, proptosis y estrabismo). El glaucoma congénito se caracteriza por opacidad corneal, buftalmo (ojos grandes) y epifora.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 11 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Niño de 8 años con fiebre de 39°C por 7 días de evolución, exantema polimorfo, adenopatías cervicales, conjuntivitis bilateral no exudativa y lengua en fresa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Kawasaki
B) Mononucleosis infecciosa
C) Escarlatina
D) Artritis idiopática juvenil
E) Sarampión

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Kawasaki: fiebre ≥5 días + ≥4 criterios (exantema polimorfo, adenopatía cervical, conjuntivitis no exudativa, labios/lengua enrojecidos, edema palmoplantar). Requiere ecocardio y tratamiento con IGIV + aspirina para prevenir aneurismas coronarios.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 128 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un prescolar de 2 años, presenta un cuadro de fiebre alta, desde hace 5 días, asociado marcado decaimiento. Al examen físico presenta un exantema eritematoso en el tronco, asociado a eritema de las manos y ojo rojo. La boca muestra amígdalas congestivas y lengua enrojecida. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome pie mano boca
B) Eritema infeccioso
C) Escarlatina
D) Sarampión
E) Enfermedad de Kawasaki

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Kawasaki** (opción **E**). Es una enfermedad de Kawasaki clásica.. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 75 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un niño de 2 años presenta un cuadro de 7 días de fiebre hasta 39 grados, asociado a inyección conjuntival y boca roja con labios partidos, a lo que se agrega un exantema eritematoso generalizado. Al examen, se aprecia decaído, con fiebre de 38,8 grados, pre- senta adenopatías cervicales y se observa descamación gruesa de los dedos de las 4 ex- tremidades. Se encuentra hospitalizado, recibiendo un tratamiento adecuado. ¿Cuál es la evolución más probable en este paciente?

A) Daño permanente de las arterias coronarias
B) Recurrencia esporádica de los síntomas
C) Resolución completa, sin secuelas
D) Daño vascular periférico generalizado
E) Daño a las válvulas cardíacas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una enfermedad de Kawasaki y con adecuado tratamiento (IgG ev más aspirina) suele resolverse, sin secuelas.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 12 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un niño de 3 años presenta un cuadro de 6 días de evolución de fiebre hasta 39,2°C, asociado a malestar general y aparición de un rash eritematoso en tronco y extremidades. Al examen físico está decaído y febril a 38,7°C, se objetiva la presencia del rash descrito y se palpan adenopatías en la cadena cervical anterior e induración de la cicatriz de la vacuna BCG. Además de solicitar hemograma, VHS y PCR, el examen de elección para continuar el estudio es:

A) Títulos de anticuerpos antiestreptolisina O
B) Procalcitonina
C) PCR para Mycobacterium tuberculosis
D) Ecocardiograma
E) Serología para virus de Epstein Barr

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Enfermedad de Kawasaki: El cuadro clínico es compatible con esta enfermedad, la que requiere una evaluación con ecocardiograma para identificar posibles aneurismas coronarios, que determinan el pronóstico y son la complicación clásica. El tratamiento consiste en la administración de inmunoglobulina G intravenosa y aspirina.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 53 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un niño de 8 años de edad presenta un cuadro de aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores y en los glúteos, asociado a dolor en ambos tobillos, a lo que luego se agrega dolor abdominal y vómitos. Al examen presenta lesiones eritematosas solevantadas en las zonas descritas, aumento de volumen en ambos tobillos y dolor abdominal difuso a la palpación. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de esta enfermedad?

A) Hemograma
B) Sedimento de orina
C) LDH
D) Perfil bioquímico
E) VHS

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un púrpura de Schönlein Henoch, cuyo pronóstico depende principalmente de la afectación renal. Se pide un sedimento de orina para determinar si hay glomerulonefritis y también creatinina para ver s hay insuficiencia renal y luego se sigue con examen de orina completa (muestra la hematuria y la proteinuria que pueden persistir, deteriorando el pronóstico).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 120 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Niño con lesiones eritematosas en miembros inferiores (foto) con artralgias de tobillos de 2 días de evolución y dolor abdominal. Al examen físico presenta edema de ambos tobillos, con lesiones en las piernas, como las que se muestran en la siguiente imagen: Considerando las complicaciones frecuentes del cuadro, es importante solicitar:

A) Creatininemia
B) Hematocrito
C) Plaquetas
D) Protombinemia
E) Proteina C reactiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis e Insuficiencia renal. Es normal que se pregunte varias veces lo mismo en el Eunacom.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 21 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Lactante 2 meses, cuadro de 7 días de fiebre, adenopatías, inyección conjuntival. a. Kawasaki

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Control sano habitual). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 126 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un escolar de 8 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades infe- riores, consistentes en pápulas eritematosas, palpables. Refiere además artralgias mi- gratorias en las manos, rodillas y codos, y también hematoquezia en algunas oportuni- dades desde hace algunos días ¿Cuál es la complicación más probable en el mediano plazo?

A) Aneurismas coronarios
B) Infartos cerebrales
C) Hepatitis
D) Daño vascular periférico
E) Nefritis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Nefritis). Es un púrpura de Schönlein Henoch, que suele producir glomerulonefritis.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 30 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un niño de 7 años es traído por su madre por un cuadro de una semana de evolución de aparición de lesiones eritematosas en ambas extremidades inferiores, a lo que se agregó dolor y edema en los tobillos. Al examen físico, se observa aumento de volumen en ambos tobillos, doloroso a la palpación. Se solicita hemograma, que resulta normal, al igual que el examen de orina completa y los niveles plasmáticos de creatinina. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Prednisona
B) Paracetamol
C) Gammaglobulina endovenosa
D) Ibuprofeno
E) Colchicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Púrpura de Schönlein-Henoch con complicaciones: El cuadro clínico sugiere una púrpura de Schönlein-Henoch, que generalmente se observa. Sin embargo, en presencia de complicaciones como falla renal, artritis o dolor abdominal, se recomienda el manejo con corticoides orales, específicamente prednisona.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 17 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Niño con fiebre de 7 días, ojo rojo, lengua roja, adenopatías cervicales y exantema maculopapular. ¿Cuál es la complicación más probable?

A) Artritis reactiva
B) Miocarditis aguda
C) Aneurismas coronarios
D) Meningitis aséptica
E) Uveítis anterior

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Aneurismas coronarios). Aneurismas coronarios. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 49 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un niño de 5 años presenta un cuadro de 7 días con fiebre alta, que no ha respondido al uso de antipiréticos, alcanzado peaks febriles de hasta 39°C. Al examen físico tiene T°: 38,6°C, pulso regular a 110x', inyección conjuntival bilateral, lengua muy enrojecida, faringe eritematosa, cuello con adenopatías submandibulares y presencia de un exantema eritematoso en el tronco y la zona genital. ¿Cuál es la complicación más probable?

A) Glomerulonefritis
B) Pericarditis
C) Hepatitis
D) Rotura esplénica
E) Aneurisma coronario

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Aneurisma coronario). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Glomerulonefritis, Pericarditis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 26 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un niño presenta aparición de lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, hace 7 días, las que se muestran más abajo, a lo que se ha agregado edema de ambos tobillos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para identificar una complicación frecuente de esta patología?

A) Creatininemia
B) Coronariografía
C) Recuento de plaquetas
D) Radiografía de pelvis
E) Velocidad de eritrosedimentacón

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una púrpura de Schönlein Henoch y su complicación más importante y que marca el pronóstico es la GNA con la consecuente falla renal. De hecho, no solo se pide la creatinina, sino también sedimento y proteinuria.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 60 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un niño de 4 años presenta un cuadro de 2 días de evolución de aparición de múltiples lesiones eritematosas en las extremidades inferiores, palpables, asociado a dolor abdominal difuso y dolor de ambos tobillos. Al examen físico se palpa abdomen blando, depresible, doloroso leve, de manera difusa, sin signos peritoneales y los tobillos se aprecian aumentados de volumen, con dolor a la movilización. ¿Qué examen es más adecuado para definir el pronóstico de la enfermedad descrita?

A) Perfil bioquímico
B) Biopsia de médula ósea
C) Hemograma
D) Sedimento de orina
E) LDH

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un púrpura de Schönlein Henoch, que se complica con glomerulonefritis. El compromiso renal marca el pronóstico. De hecho, luego se sigue con orina completa (para ver la proteinuria y la hematuria).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 135 2.01.1.058 · Vasculitis: PSH, Kawasaki,

Un paciente de 17 años consulta por aparición de lesiones en las extremidades inferiores. Al interrogatorio, refiere que desde hace 5 días presenta dolor abdominal asociado a deposiciones diarreicas con estrías de sangre y que ha notado aumento de volumen en ambos tobillos. Hace un día nota aparición de lesiones eritematosas en ambas piernas que han aumentado de tamaño y can8dad. Al examen Fsico se observan petequias y pápulas violáceas palpables en ambas piernas y zona glútea. Entre sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 42%, hemoglobina: 13,1 g/dL, glóbulos blancos: 8.400/mm³ y plaquetas: 200.000/mm³. Refiere que ha tomado an8inflamatorios para el manejo del dolor abdominal. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Enfermedad de Kawasaki
B) Púrpura trombocitopénica inmune
C) Eritema nodoso
D) Púrpura de Schönlein-Henoch
E) Reacción a fármacos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una Púrpura de Schönlein-Henoch clásica. Suele tener hemograma normal (no es trombocitopénica). Sus síntomas más frecuentes son 4: púrpura palpable de extremidades inferiores (puede afectar glúteos y extremidades superiores), compromiso renal (glomerulonefriGs, hematuria, falla renal), compromiso gastrointestinal (dolor abdominal, hematoquecia) y compromiso articular (artralgias y artriGs).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 118 2.01.1.108 · Dermatitis del pañal y de

Lactante con eritema del pañal que no responde a óxido de zinc y muestra lesiones satélite. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Clotrimazol tópico
B) Mupirocina tópica
C) Hidrocortisona tópica 1%
D) Óxido de zinc en mayor concentración
E) Fluconazol oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Clotrimazol tópico** (opción **A**). Clotrimazol tópico. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 65 2.01.1.108 · Dermatitis del pañal y de

IMAGEN: Lactante con dermatitis del pañal (foto), con tratamiento previo con óxido de zinc, cual es el tratamiento:

A) Clotrimazol tópico (cándida clotrimazol tópico, según yo era esta porque se veían lesiones satélite)
B) betametasona. c. Hidrocortisona topica
C) Control sano habitual
D) Derivar a especialista
E) Hospitalizar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Clotrimazol tópico (cándida clotrimazol tópico, según yo era esta porque se veían lesiones satélite)** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 142 2.01.1.108 · Dermatitis del pañal y de

Una lactante de 6 meses, presenta eritema del pañal, desde hace 7 días, que no ha mejorado a pesar de realizar cambios frecuentes del pañal y de aplicar óxido de zink. Usa pañal desechable y se alimenta con lactancia materna exclusiva. Al examen físico, se aprecia lo siguiente (fuente: https://idermumbert.com/dermatologia): ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Mupirocina tópica
B) Betametasona tópica
C) Vaselina tópica
D) Clotrimazol tópico
E) Pimetacrolimus tópico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Clotrimazol tópico** (opción **D**). Fisiología De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Mupirocina tópica, Betametasona tópica) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 106 2.01.1.108 · Dermatitis del pañal y de

Una lactante de 4 meses presenta lesiones eritematosas en la zona del pañal, por lo que su madre ha iniciado aplicación de pomadas de óxido de zinc y realizado cambios frecuentes del pañal; a pesar de ello, las lesiones no han mejorado y han aumentado, observándose como en la imagen que se muestra a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aplicar cor2coides tópicos
B) Aplicar mupirocina tópica
C) Suspender el uso de pañal
D) Iniciar fluconazol oral
E) Aplicar clotrimazol tópico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una candidiasis del pañal tanto por la falta de respuesta, como por la imagen, con lesiones satélites y compromiso de los pliegues. Se trata con antimicóticos tópicos. Fuente imagen: hxps://www.luciamipediatra.com.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 70 2.01.1.108 · Dermatitis del pañal y de

Un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de dermatitis del pañal presenta aparición de lesiones eritematosas y pruriginosas en los muslos, que se muestran en la imagen: El tratamiento más adecuado es:

A) Antimicóticos tópicos en crema
B) Corticoides tópicos en crema
C) Antibióticos tópicos en crema
D) Aciclovir tópico
E) Vaselina tópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien en la foto original parecían ectimas bacterianos en la foto, lo que se preguntaban eran las lesiones satélite en el muslo del lactante, por lo que se trataba de una candidiasis.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 128 2.01.1.010 · Hepatitis viral

Una niña de 8 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y aparición de ictericia asociado a orinas oscuras que se identifica como coluria. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran GOT 1.525UI/L, GPT 1.216 UI/L, bilirrubina total 11,3mg/dL de predominio directo e IgM para VHA (+). Se indica reposo por 10 días evolucionando favorablemente, sin embargo, 10 días después reaparece la ictericia, agregándose pruri- to y astenia. Se controlan pruebas hepáticas que muestran protrombinemia: 90%, GOT: 1.025 UI/L y GPT: 968 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hepatitis crónica
B) Remisión completa
C) Portación asintomática del virus
D) Remisión parcial con recurrencias
E) Falla hepática

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Remisión parcial con recurrencias** (opción **D**). Es una hepatitis A recurrente (una de las forma de presentación de la hepatitis A).. Clase sobre el enfoque global de la ictericia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 79 2.01.1.010 · Hepatitis viral

Adolescente de 15 años con cuadro de 5 días de evolución con fiebre, astenia, náuseas, ictericia, a lo que últimamente se ha agregado prurito. Ha tomado Paracetamol (500 mg), un total de 6 tabletas. Al examen físico, hipocondrio derecho levemente sensible a la palpación. Tiene antecedente de haber estado en un campamento hace 1 mes. En sus exámenes tiene fosfatasas alcalinas y GGT: 8 veces por encima del valor normal; y transaminasas: 20 veces por encima del valor normal; bilirrubinemia aumentada. ¿Cuál es el diagnóstico probable?

A) Colecodolitiasis
B) Hepatitis A
C) Hepatitis C
D) Hepatitis por fármacos
E) Hepatitis autoinmune

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una hepatitis aguda, cuya primera causa es la hepatitis A. Además, la clínica es compatible: pródromo febril, seguido de ictericia. La cantidad de paracetamol que ha tomado no alcanza a producir hepatitis ni aunque se lo tomara todo junto.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 144 2.01.1.010 · Hepatitis viral

¿Cuál es la conducta más adecuada ante un recién nacido, cuya madre tiene el diagnóstico de hepatitis B?

A) Administrar la vacuna anti-VHB e inmunoglobulina anti-VHB al niño
B) Prohibir la lactancia materna
C) Dar antivirales al niño
D) Solicitar pruebas hepáticas al niño
E) Observar evolución

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Administrar la vacuna anti-VHB e inmunoglobulina anti-VHB al niño** (opción **A**). Esa es la conducta.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 3 2.01.1.105 · Alteraciones pigmentarias

Un lactante de 12 meses de edad es traído por su madre, ya que presenta coloración amarillenta-anaranjada en las palmas de las manos, las plantas y en las mejillas. No tie- ne otros antecedentes, pesa 9,5 Kg y mide 73,5 cm y su examen físico no muestra otras alteraciones. ¿Cuál es la causa de esta alteración?

A) Hipercolesterolemia
B) Hipertrigliceridemia
C) Hiperbilirrubinemia de predominio directo
D) Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto
E) Un componente de la dieta

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Un componente de la dieta). Por ingesta de betacaroteno. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 82 2.01.1.105 · Alteraciones pigmentarias

Una niña de 5 años, con antecedentes de atopia, consulta por presentar lesiones hipo pigmentadas en el rostro, no pruriginosas, ni dolorosas con descamación amarilla como se muestra en la siguiente imagen: La indicación más adecuada es:

A) Crema de hidricortisona tópica
B) Crema de betametasona tópica
C) Crema de clotrimazol tópico
D) Griseofulvina oral
E) Bloqueador solar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pitiriasis alba. Por regla general se observa y se humecta, porque está asociada a atopía, pero el bloqueador solar está indicado (la verdad es que está indicado en todas las personas).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 40 2.01.2.014 · Intoxicaciones

Una niña de 2 años ingirió muchas pastillas, que había en la casa. Al examen físico, está inconsciente, pálida e hipotónica, con pulso a 117 por minutos, frecuencia respiratoria de 38 por minuto y pupilas arreactivas a la iluminación. ¿Qué fármacos son los más probablemente ingeridos?

A) AINES
B) Benzodiacepinas
C) Salicilatos
D) Opiáceos
E) Antidepresivos tricíclicos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una intoxicación por tricíclicos por el compromiso de conciencia, taquicardia y pupilas arreactivas (en midriasis). No puede ser benzodiacepinas ni opiáceos, porque no tenía disminución de la frecuencia respiratoria. AINEs y salicilatos no afectan las pupilas.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 108 2.01.2.014 Intoxicaciones

Un niño de 4 años, hace 24 horas ingiere 7 comprimidos de algún medicamento desconocido, evolucionando con malestar general, vómitos e ictericia. Se solicitan exá- menes, en los que destaca GOT: 403 UI/L, GPT: 390 UI/L, bilirrubina plasmática total: 5,2 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar L-carnitina endovenosa
B) Administrar deferoxamina endovenosa
C) Administrar N-acetil-cisteína endovenosa
D) Administrar carbón activado vía oral
E) Administrar piridoxina vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se sospecha intoxicación por paracetamol. Dado la hepatitis. Aún está en ventana para darle la N-acetil-cisteína.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 81 2.01.2.014 Intoxicaciones

Niño de 4 años llega a urgencias con miosis puntiforme, bradicardia, hipersecreción (lagrimeo, sialorrea, broncoespasmo) y compromiso de conciencia. Antecedente de acceso a bodega con pesticidas. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Hospitalizar: atropina EV + pralidoxima + lavado gástrico
B) Derivar a especialista de forma ambulatoria
C) Control sano habitual
D) Observación domiciliaria 24h
E) Solo anticonvulsivantes EV

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome colinérgico por organofosforados (pesticida): miosis + bradicardia + hipersecreción + compromiso neurológico = emergencia. Tratamiento: atropina EV a dosis altas (antídoto) + pralidoxima (reactiva AChE si precoz) + hospitalización.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 28 2.01.2.014 Intoxicaciones

Niño que juega en huerto que evoluciona con sialorrea y miosis a. Intoxicación por organofosforado

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Control sano habitual). 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 41 2.01.2.014 Intoxicaciones

Un niño de edad presenta un cuadro de agitación, alternado con obnubilación, asociado a vómitos, sialorrea, diarrea, dolor abdominal, taquicardia, tos, temblor y sudoración. Se sospecha que haya ingerido algún tóxico. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Administrar antieméticos
B) Administrar omeprazol
C) Administrar solución glucosada al 10%
D) Administrar N-acetil.cisteína
E) Administrar atropina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un síndrome colinérgico clásico (lo más probable es que consumió insecticidas), por lo que debe recibir atropina como antídoto. Revisar los síndromes de las intoxicaciones en psiquiatría.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 95 2.01.2.014 Intoxicaciones

Una niña de 5 años, ingiere accidentalmente soda cáustica, hace 45 minutos. Evoluciona con sialorrea y dolor abdominal y torácico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar carbon activado
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Administrar agente alcalinizante
D) Instalar una sonda nasogástrica y aspirar el contenido
E) Inducir los vómitos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La ingesta de cáusticos se debe estudiar con EDA precoz: si no hay lesiones, se observa; si hay lesiones leves, se deja en régimen cero y se reinicia la alimentación de a poco, en 2 días. Si hay lesiones más severas, se alimenta por SNG y si hay perforación (se puede ver en la RxTx como neumomediastino), se debe hacer cirugía de inmediato, porque las perforaciones evolucionan a mediastinitis aguda, que son cuadros muy graves. Las demás medidas o no tienen utilidad o están contraindicadas en la ingesta de álcalis.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 136 2.01.5.005 Osteoclisis

Un lactante de 1 años de vida ingresa al servicio de urgencia en malas condiciones generales, soporoso, con extremidades pálidas y frías en la zona distal. Se indica hidratación endovenosa, pero, a pesar de intentarlo, es imposible acceder a un vía venosa. ¿Cuál es la vía de elección para admninistrar fluidos en este paciente?

A) Catéter venoso central
B) Línea arterial
C) Sonda nasogástrica
D) Denudación venosa
E) Osteoclisis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En los niños, al fallar la vía venosa, se prefiere la osteoclisis. En los adultos, la denudacion venosa.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 108 2.01.5.005 · Osteoclisis

Un lactante de 4 meses de edad presenta una diarrea grave, abundante, asociada a deterioro del estado general y sopor. Sus exámenes muestran elevación de la creatinina, hiponatremia e hipokalemia. Es imposible encontrar una vía venosa para para administrar fluidos, ¿cuál es el medio de hidratación más adecuada?

A) Catéter femoral
B) Catéter subclavio
C) Denudación safena
D) Vía intraósea
E) Sonda nasogástrica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La osteoclisis es la vía de elección en lactantes, cuando no es posible encontrar una vía venosa. En los adultos, en cambio, se realiza la denudación venosa.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 99 2.01.3.007 · Lactancia materna

Usted atiende a un recién nacido de 10 días de vida, junto a su madre. Nació por parto vaginal sin complicaciones, pesando 3.200 gramos al nacer y 3.050 gramos al momento del alta. La madre refiere que presenta llanto frecuente y permanece constantemente prendido al pecho, por lo que sospecha que tiene dolor abdominal. Al examen físico, el niño llora vigorosamente y se observa en buen estado general. Su peso actual es de 3.350 gramos. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este caso?

A) Agregar fórmula láctea después de cada toma
B) Indicar a la madre que suspenda el consumo de lácteos y reevaluar al niño
C) Citar a control en 24 horas
D) Reforzar la técnica de lactancia materna
E) Prescribir lactobacillus reuteri

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Peso en Recién Nacidos: Es normal que un recién nacido pierda hasta un 10% de su peso durante los primeros días de vida, el cual se recupera al cumplir los 7 días. Luego de la baja inicial, el incremento norma es de 20 a 25 g al día o más. En este caso, el recién nacido ha subido de peso adecuadamente, lo que sugiere que es un recién nacido normal. Por estar prendido al pecho todo el día, se asume que la técnica de lactancia no es óptima. Si no hubiese subido de peso, sería correcto mejorar la técnica de lactancia y, además, citar a control en 24 horas. El Lactobacillus reuteri se indica en los cólicos, pero son poco probables a esta edad..

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 109 2.01.3.007 · Lactancia materna

Un lactante de 3 meses de edad pesa 7 kg. Se alimenta con lactancia materna exclusiva a libre demanda. Tiene peso para la edad en +1 DS y el índice peso/talla en +2 DS. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dar formula de relleno
B) Amamantar cada 4 horas
C) Dar agua entre cada toma
D) Mantener la lactancia materna a libre demanda
E) Supender la lactancia nocturna

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy discutible. Aunque esté con lactancia materna exclusiva, hoy se considera obeso (para el diagnóstico de obesidad manda el IPT en menores de 1 año; en cambio para el diagnóstico de desnutrición se usa el IPE hasta el año de edad). Sin embargo, si está con LME, no es necesario tomar ninguna medida, ni siquiera espaciar las tomas, hasta los 6 meses.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 17 2.01.1.067 · Síndrome hemolítico urémic

Un lactante de 3 años presenta, desde hace 2 días, edema de extremidades inferiores, de la cara y de la zona escrotal, asociado a malestar general. Hace 4 días está con diarrea. Al examen físico se aprecia pálido, se constata el edema blando y se observan múltiples equimosis en las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes que muestran creatinina: 3,0 mg/dl, BUN: 35 mg/dl, hemograma con hematocrito: 28%, plaquetas: 120.000, blancos: 11.000 por mm3, frotis con esquistocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome nefrótico
B) Púrpura de Schönlein Henoch
C) Insuficiencia renal prerrenal
D) Glomerulonefritis aguda posestreptocócica
E) Síndrome hemolítico urémico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un SHU clásico: falla renal, anemia hemolítica y plaquetopenia. Suele estar precedido por diarrea en el 70% de los casos. La IRA prerrenal no tiene edema.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 122 2.01.1.067 · Síndrome hemolítico urémic

Una niña de 3 años presenta, hace 4 días, un cuadro de diarrea y fiebre hasta 38ºC, a la que se agrega sangre en las deposiciones, 48 horas después. En su examen físico se ve decaída, pálida y en sus exámenes destaca hematocrito de 28%, leucocitos 9.800, plaquetas 75.000, BUN 28, creatinina 2,3 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Leucemia aguda
B) Síndrome hemolítico urémico
C) Shock Séptico
D) Glomerulonefritis aguda
E) Púrpura de Schölein Henoch

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un SHU clásico (niño, antecedente de diarrea, insuficiencia renal aguda grave, anemia hemolítica y trombocitopenia).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 61 2.01.1.067 · Síndrome hemolítico urémic

Un niño de 5 años es hospitalizado por una neumonía con hemocul8vos posi8vos para Streptococcus pneumoniae. Está en tratamiento con cejriaxona endovenosa. Al tercer día evoluciona con deterioro del estado general y oliguria, por lo que se solicitan exámenes que muestran crea8nina: 3,1 mg/dL, BUN: 68 mg/dL, hemograma con hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dL, glóbulos blancos: 13.000/mm³, 70% de neutrófilos y plaquetas 70.000/mm³, el 8empo de protrombina resulta 16,2 segundos y los niveles de complemento muestran C3: 81 mg/dL (normal: 90–180 mg/dL) y C4: 8,5 mg/dL (normal: 11–40 mg/dL). El sedimento de orina muestra hematuria con 15% de dismorfia. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Coagulación intravascular diseminada
B) Glomerulonefri2s aguda posinfecciosa
C) Síndrome hemolí2co urémico
D) Sepsis por neumococo
E) Insuficiencia renal aguda prerrenal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome hemolítico urémico (SHU) clásico, cuyas causas más frecuentes son infecciones por 1. Escherichia coli enterohemorrágica, 2. Shigella, 3. Streptococcus pneumoniae y 4. otras bacterias como Campylobacter, Salmonella y Mycoplasma. El SHU se caracteriza por una insuficiencia renal aguda con anemia hemolítica y plaquetopenia. Puede tener hematuria dismórfica e incluso hipocomplementemia, como en este caso. A pesar de que Gene varios elementos de la glomerulonefriGs posGnfecciosa (falla renal, hipocomplementemia, hematuria dismórfica), esta suele ocurrir varios días después de la infección y no en agudo y generalmente es por Streptococcus pyogenes y no Gene plaquetopenia (sí puede tener algo de anemia dilucional).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 177 2.01.1.126 · Síndrome distress respirat

Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, nacido por cesárea, presenta dificultad respiratoria, luego de nacer, con taquipnea, retracción subcostal y crepitantes basales. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra ambos campos pulmonares con hiperinsuflación, reforzamiento hiliar, aplanamiento del diafragmas y silueta cardiaca normal. El diagnóstico más probable es:

A) Neumomediastino
B) Neumonía connatal
C) Taquipnea transitoria
D) Enfermedad de membrana hialina
E) Cardiopatía congénita

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Taquipnea transitoria** (opción **C**). Tanto por el antecedente de cesárea, como por la radiografía es taquipnea transitoria clásica.. El síndrome de distress respiratorio del recién nacido (SDR) agrupa todas las causas de dificultad respiratoria neonatal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 120 2.01.1.007 · Enteroparasitosis

Un niño de 4 años presenta intenso prurito anal, desde hace varios días, lo que se ha asociado a dificultades para dormir y bruxismo. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?

A) Parasitológico de deposiciones
B) Test de Graham
C) Hemograma
D) Prueba de reacción cutánea a la escoriación (Prick test)
E) Recuento de inmunoglobulina E específica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Test de Graham). Parece una oxiuriasis, que se diagnostica con el test de Graham.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 125 2.01.1.007 · Enteroparasitosis

Una niña de 5 años persenta prurito anal importante, asociado a prurito vulvar. La madre refiere que también presenta bruxistmo. Al examen físico presenta signos de grataje en la zona perianal y perivulvar. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Parasitológico seriado
B) Test de Graham
C) Microscopía óptica de frotis directo de deposiciones
D) Coprocultivo
E) Medición de eosinófilos en sangre

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Test de Graham** (opción **B**). La oxiuriasis se diagnostica con el test de Graham.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 143 2.01.1.007 · Enteroparasitosis

Un niño de 7 años es llevado a consulta por prurito anal intenso, mayor en las noches, de 2 semanas de evolución. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, con signos vitales y examen abdominal normales. El examen anal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada para continuar el estudio de este paciente?

A) Colonoscopía
B) Examen directo de heces
C) Examen parasitológico de deposiciones
D) Test de Graham
E) Serología para Enterobius vermicularis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico de Enterobiasis: El test de Graham es el examen de elección para diagnosticar enterobiasis (oxiuariasis). Recolecta los huevos del parásito en la zona perianal, utilizando una cinta adhesiva, con mayor efectividad que los análisis parasitológicos convencionales.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 122 2.01.1.005 · Celulitis periorbitaria

Una niña de 4 años presenta un cuadro catarral, con abundante rinorrea. Evoluciona con eritema y, dolor periocular derecho, asociado a proptosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probablem?

A) Celulitis preorbitaria
B) Celulitis orbitaria
C) Orbitopatía distiroidea
D) Pseudotumor orbitario
E) Etmoiditis aguda

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Celulitis orbitaria** (opción **B**). La proptosis hace que sea orbitaria. En este caso es secundaria a una sinusitis.. La pérdida lenta de visión es uno de los motivos de consulta oftalmológica más frecuentes en adultos y tiene tres causas principales que el médico general debe conocer: cataratas, degeneración macular relacionada con la edad y glaucoma crónico de ángulo abierto. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 126 2.01.3.003 · Diagnóstico nutricional

Un lactante de 4 meses, alimentado con lactancia materna exclusiva, tiene índice talla edad: normal, índice peso edad: normal e índice peso talla: +1. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional de acuerdo a la OMS y el Minsal?

A) Desnutrición
B) Riesgo de desnutrición
C) Eutrófico
D) Riesgo de obesidad
E) Obesidad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En menores de 1 año se usa el IPE para el diagnóstico de desnutrición y el IPT para el de sobrepeso. Como tiene IPE normal, no hay desnutrición. Como su IPT es +1, tiene sobrepeso.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 41 2.01.3.003 · Diagnóstico nutricional

Usted evalúa a una niña de 4 meses, cuyos índices antropométricos muestran índice peso/edad: normal, índice talla/edad: normal e índice peso/talla: +1. De acuerdo a las recomendaciones de diagnóstico nutricional infantil de la OMS – Ministerio de Salud, el diagnóstico más adecuado es:

A) Desnutrición
B) Riesgo de desnutrición
C) Eutrofia
D) Riesgo de obesidad
E) Obesidad

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo primero a mirar en los menores de 1 año es el índice peso/edad, buscando solo desnutrición (-2 o menos) o riesgo de desnutrición (-1 a -1,9). Si está normal, se mira el índice peso/talla, en busca de obesidad (+2 o más) o sobrepeso (+1 a+1,9, que se registran como +1). Si no cumple con Los criterios anteriores, pues está eutrófico. En los mayores de 1 año se mira solo el IP/T. En los mayores de 5 años, se mira solo el IMC.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 72 2.01.3.003 · Diagnóstico nutricional

Un recién nacido de 10 días pesó 3.100 gramos al nacer. Se alimenta con lactancia materna exclusiva y actualmente pesa 3.180 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional?

A) Desnutrición
B) Riesgo de desnutrición
C) Sobrepeso
D) Buen incremento ponderal
E) Mal incremento ponderal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Considerando que es normal que bajen de peso, hasta un 10% del peso y que lo recuperen a los 7 días, su incremento de peso es del todo normal.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 131 2.01.1.109 · Ectoparasitosis

Una prescolar de 4 años presenta prurito en la cabeza. Al examen físico se ven abundantes liendres, a menos de 3 cm del cuero cabelludo, sin visualizar piojos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Ivermectina oral
B) Permetrina tópica al 1%
C) Permetrina tópica al 5%
D) Lindano tópico
E) No tratar, mientras no se visualicen piojos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto los piojos, como las liendres, son diagnósticas de pediulosis (a menos que las liendres estén muy alejadas del cuero cabelludo, ya que serían antiguas). La pediculosis se trata con permetrina al 1%.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 144 2.01.1.109 · Ectoparasitosis

Niño de 8 años con lesiones eritematosas papulosas en manos, pies, axilas y zona interdigital, muy pruriginosas, que empeoran de noche. También afectados su hermano y su madre. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A) Escabiosis: permetrina 5% tópica + tratar a todos los contactos
B) Dermatitis atópica: emolientes y corticoides tópicos
C) Tinea pedis: clotrimazol tópico
D) Erupción por contacto: evitar alérgeno
E) Impétigo: mupirocina tópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Sarna (escabiosis): prurito nocturno + lesiones en espacios interdigitales, axilas, manos y pies + afecta convivientes = Sarcoptes scabiei. Tratamiento: permetrina 5% cuerpo completo + tratar todos los contactos simultáneamente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 50 2.01.5.002 · Atención inmediata del rec

Recién nacido de término por parto vaginal, con líquido amniótico claro. Al nacer llora inmediatamente, frecuencia cardíaca 145 lpm, buen tono muscular, piel rosada. ¿Cuál es la primera maniobra a realizar?

A) Aspiración rutinaria de vías aéreas
B) Contacto piel a piel con la madre (apego precoz)
C) Vitamina K intramuscular
D) Profilaxis ocular con eritromicina
E) Oxígeno suplementario

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
RN vigoroso con líquido claro: según guías NRP 2020, NO se realiza aspiración rutinaria. El primer paso es proporcionar calor y APEGO PRECOZ (piel a piel). Vitamina K y profilaxis ocular se realizan después, pero el apego inmediato es la primera prioridad en el RN sano.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 137 · 2.01.5.002 · Atención inmediata del rec

Un recién nacido presenta aumento de volumen en la cabeza. Al examen físico se aprecia blando y fluctuante, sin sobrepasar la línea media. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Absceso de cuero cabelludo
B) Cefalohematoma subperióstico
C) Meningocele
D) Hemorragia intracerebral
E) Bolsa serosanguínea

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Cefalohematoma subperióstico** (opción **B**). Es un cefalohematoma clásico.. 1. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Absceso de cuero cabelludo, Meningocele) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 142 · 2.01.1.004 · Adenitis cervical

Un escolar de 6 años presenta aumento de volumen submandibular derecho, doloroso. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen, de aspecto eritematoso, de 3 cm de diámetro, doloroso a la palpación. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Bacteroides fragillis
B) Peptoestreptococo
C) Streptococcus tipo A
D) Staphilococcus aureus
E) Escherichia coli

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parecía una adenitis supurada o una sialoadenitis submandibular. Ambas son por S. aureus y S. Pyogenes, pero al abscedarse, lo más probable es S. aureus.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 146 · 2.01.3.001 · Alimentación normal

Una lactante de 7 meses se alimenta con 4 mamaderas al día, de leche purita fortificada al 7,5% más cereal al 5%, más 1 sopa puré. ¿Qué suplemento alimenticio debería estar recibiendo?

A) Tiamina
B) Zink
C) Vitamina A
D) Vitamina D
E) Ácido fólico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Vitamina D). En la práctica también recibe vitamina A (vitaminas ACD), pero es la vitamina D la importante.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 122 · 2.01.3.001 · Alimentación normal

Usted atiende a un lactante de 10 meses de edad, con antecedente de haber nacido prematuro a las 30 semanas y que pesó 1.300 gramos al nacer. Según el Plan Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), ¿qué tipo de leche debe recibir?

A) Fórmula de inicio
B) Fórmula de continuación
C) Leche purita fortificada
D) Fórmula de inicio para prematuros
E) Fórmula de continuación para prematuros

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Eso dice el PNAC, así que ya saben: según Asofamech, hay que saberlo. No debería preguntarse este tipo de cosas.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 158 · 2.01.2.024 · Síndrome convulsivo

Un lactante de 15 meses de edad presenta una convulsión tónico-clónica de 1 mi- nuto de duración, autolimitada, mientras cursaba con fiebre de 39 grados Celsius. Al examen está bien perfundido, algo pálido, consciente, con pulso y presión arterial nor- males, sin signos focales, ni signos meníngeos. El resto de su exploración, no presenta hallazgos de importancia. Además de bajar la temperatura del niño ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar punción lumbar
B) Iniciar diazepam
C) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
D) Iniciar ácido valproico
E) Mantener en observación por 4 horas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una comvulsión febril benigna. No tiene signos que hagan sospechar me- ningitis y por ser la primera convulsión, tampoco es necesario iniciar naticonvulsivantes.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 33 · 2.01.2.024 · Síndrome convulsivo

Un lactante de 18 meses de edad, presenta un convulsión tónico-clónica de 3 minu- tos de duración. Al examen físico está afebril, sin alteraciones en el examen segmenta- rio. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis?

A) Diazepam
B) Ácido valproico
C) Fenitoína
D) Carbamazepina
E) Topiramato

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Preguntan el tratamiento de la crisis y las crisis convulsivas se tratan preferente- mente con benzodiacepinas, aunque la de elección es el lorazepam.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 62 2.01.1.040 · Diarrea crónica

Un niño de 3 años presenta diarrea de 3 meses de evolución, intermitente, general- mente acuosa, pero que en ocasiones contiene escasos restos vegetales. Ha subido 600 gramos en ese periodo y su talla es 90 cm. Tiene signos vitales normales, se aprecia hi- dratado y su examen abdominal muestra un abdomen blando, depresible e indoloro, sin visceromegalia ni otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

A) Diarrea crónica inespecífica
B) Enfermedad celíaca
C) Enteropatía perdedora de proteínas
D) Alergia a la proteína de la leche de vaca
E) Intolerancia a los disacáridos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Diarrea crónica inespecífica** (opción **A**). Es una diarrea crónica inespecífica clásica. Se produce por consumo excesivo de jugos hiperosmolares.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 67 2.01.2.010 · Hemorragia digestiva

Un lactante de 8 meses, presenta un cuadro de malestar general y vómitos alimenta- rios en varias oportunidades, durante las últimas horas. En el último episodio de vómi- tos, se agregó escasa hematemesis, por lo que acude al servicio de urgencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esofagitis péptica
B) Esofagitis erosiva
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Gastritis erosiva
E) Gastritis por Helicobacter pylori

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome de Mallory Weiss** (opción **C**). Es un Sd. De Mallory Weiss clásico. :::warning No confundirlos — el manejo es opuesto. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 36 2.01.2.010 · Hemorragia digestiva

Un niño de 3 años de edad es traído al servicio de urgencia, ya que desde hace 24 horas que ha presentado diarrea y múltiples episodios de vómitos alimentarios. El día anterior había consultado por la misma razón, recibiendo indicación de sales de rehidratación por vía oral. Sin embargo, persistió con los síntomas, presentando vómitos frecuentes, de los cuales, el último episodio vomitó sangre. Al examen físico, tienen signos de deshidratación y está taquicárdico, con llene capilar normal. ¿Cuál es la causa más probable de su hemorragia digestiva?

A) Gastritis erosiva
B) Úlcera gastroduodenal
C) Síndrome de Mallory Weiss
D) Lesión de Dieulafoy
E) Várices esofágicos rotos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome de Mallory-Weiss: Se trata de un síndrome de Mallory-Weiss clásico, en el que la hemorragia digestiva se debe a una erosión esofágica causada por vómitos intensos. Es importante diferenciarlo del síndrome de Boerhaave, que implica una perforación esofágica con dolor torácico y mediastinitis, también tras vómitos severos.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 109 2.01.1.131 · Sinequias vulvares

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar parcial, de los labios menores. No tie- ne desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

A) Realizar lavados con ácido acéticos
B) Aplicar corticoides tópicos
C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
D) Indicar antibióticos
E) Realizar aseo y masajes en la zona

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta difícil, ya que en distintas partes se manejan de manera diferen- te. Sin embargo, la mayor evidencia dice que el aseo es lo más importante para que se resuleva. Los masajes pueden ayudar a que se desprenda antes.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 154 2.01.1.131 · Sinequias vulvares

Una niña de 4 años presenta sinequia vulvar que une gran parte de los labios menores, por lo que impide ver el introito y el himen. No tiene desarrollo puberal, ni antecedentes de infecciones urinarias, ni genitales. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

A) Realizar lavados con ácido acético
B) Aplicar corticoides tópicos
C) Remover las sinequias de manera quirúrgica
D) Realizar separación manual bajo anestesia local
E) Indicar lubricación diaria con vaselina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las sinequias vulvares asintomáticas en niñas se pueden observar, aunque se pueden manejar con lubricación y aseo. En caso de que se compliquen con infecciones u otra molestia (infrecuente), se pueden liberar mediante separación manual con anestesia local. Vale la pena recordar que no son alteraciones congénitas, sino que aparecen después y suelen desaparecer con la llegada de la pubertad.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 179 2.01.1.131 · Sinequias vulvares

Una niña de 2 años de edad es traída por su madre a control de niño sano. Al examen físico se objetivan genitales con labios menores completamente adheridos entre sí en la línea media, lo que impide la visualización de la vagina y el meato urinario. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Resección quirúrgica de las adherencias
B) Realizar avulsión digital, bajo anestesia local con lidocaína
C) Indicar aseo genital diario con vaselina líquida
D) Aplicar pantenol tópico en la zona perineal por 15 días
E) Aplicar betametasona tópica en la zona afectada por 10 días

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Manejo de las Sinequias Vulvares: El tratamiento de las sinequias vulvares (adherencias labiales) es controvertido. La mayoría de los casos son asintomáticas y solo requieren observación. Sin embargo, el tratamiento tópico con estrógenos o corticosteroides se considera para las sinequias extensas (este caso), las que desvían el flujo urinario, causan dolor, o se asocian con flujo o infecciones recurrentes (vaginales o urinarias). Si en estos casos no hay mejoría después del tratamiento tópico, se puede considerar la cirugía. La cirugía también está indicada si las sinequias obstruyen completamente el flujo urinario.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 32 2.01.1.095 · Conjuntivitis aguda

Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral, desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival y escasa secreción bilateral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Neisseria meningitidis
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Streptococcus agalactiae
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto gonococo como clamidia producen conjuntivitis neonatal, pero la gonorrea suele ser muy purulenta y aparecer en la primera semana de vida. La clamidia, en cambio, puede demorar más (algunas semanas), ser menos purulenta y asociarse a neumonía, similar a las neumonías atípicas.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 39 2.01.1.095 · Conjuntivitis aguda

Un recién nacido de 20 días de vida, cuyo embarazo no fue controlado y que tiene antecedente de haber nacido por parto vaginal en su casa, es traído por presentar secreción ocular bilateral, desde hace 5 días. Al examen físico se aprecia eritema conjuntival bilateral con escasa secreción. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Neisseria meningitidis
B) Neisseria gonorrhoeae
C) Streptococcus pneumoniae
D) Streptococcus agalactiae
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Chlamydia trachomatis). fijo/constante, se debe derivar al oftalmólogo.. Positiva (parto progresa) → continuar vía vaginal. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 22 2.01.1.095 · Conjuntivitis aguda

Niño con fiebre, odinofagia, ojo rojo bilateral y conjuntivitis. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Aseo ocular con suero fisiológico
B) Colirio antibiótico tópico
C) Aciclovir oftálmico
D) Azitromicina oral
E) Clorfenamina oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Aseo ocular con suero fisiológico** (opción **A**). Aseo ocular con suero fisiológico. Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 123 2.01.1.095 · Conjuntivitis aguda

Un niño de 4 años presenta sensación febril y ojo rojo bilateral, asociado a ardor y lagrimeo, lo que se acompaña de rinorrea y odinofagia. Varios de sus familiares tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Chlamydia trachomatis
B) Staphilococcus aureus
C) Streptococcus pyogenes
D) Haemophilus influenzae
E) Adenovirus

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Adenovirus). Es una fiebre faringoconjuntival clásica por ADV.. El ojo rojo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del médico general. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 10 2.01.1.095 · Conjuntivitis aguda

Un prescolar de 4 años presenta un cuadro de una semana de evolución de fiebre, hasta 39°C, asociada a odinofagia. Además, se ha asociado ojo rojo, que inició en el lado izquierdo y al día siguiente se extendió al ojo derecho. Al examen físico, tiene faringe eritematosa, ojo rojo bilateral, con secreción mucosa escasa y se palpan adenopatías cervicales bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de sus síntomas oculares?

A) Aseo con suero fisiológico
B) Corticoide tópico
C) Ungüento de tobramicina
D) Colirio de gentamicina
E) Ungüento de cloramfenicol

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ungüento de cloramfenicol** (opción **E**). Ante cualquier signo de alarma, la conducta del médico general es derivar de urgencia al oftalmólogo sin intentar manejo. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 132 2.01.1.094 · Patología de columna

¿Qué alteración del examen físico, obliga a descartar una disrafia espinal de tipo espina bífida oculta?

A) Melanocitosis cutánea congénita
B) Nevus flammeus sacro
C) Nevo congénito en la zona sacra
D) Hoyuelo sacro o “fosita pilonidal”
E) Seno dérmico sacrococcígeo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta específica. La fosita pilonidal suele ser normal, a menos que sea atípica; en cambio el seno dérmico sacro debe estudiarse. (si es que aparecía hemangioma, tam- bién es una alteración que obliga a descartar espina bífida oculta).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 67 2.01.1.029 · Sinusitis

Un niño de 6 años, con antecedente de obstrucción nasal y rinorreas frecuentes, mayor en primavera, presenta un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por rinorrea mucosa abundante, tos y picos subfebriles hasta 37,8 °C. Inicialmente tendió a mejorar, sin embargo, desde hace 4 días se produjo un aumento en la secreción nasal, la que en ocasiones tenía mal olor, y se agregó cefalea frontal. Al examen Fsico está en buenas condiciones, con temperatura: 36,5 °C, FC: 90x' y FR: 15x', se observa faringe eritematosa con descarga posterior y se constata dolor a la percusión de la zona frontal. El examen pulmonar muestra murmullo pulmonar presente y escasos roncus bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar radiogra:a de senos paranasales
B) Iniciar amoxicilina vía oral
C) Solicitar TAC de cavidades paranasales
D) Iniciar prednisona oral
E) Solicitar nasofibroscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una sinusiGs aguda, con alta sospecha de infección bacteriana (por empeoramiento y Gempo de evolución). El diagnóstico es clínico y se trata con amoxicilina oral, como antibiótico de primera línea.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 14 2.01.1.029 · Sinusitis

Niño con 10 días de congestión nasal y rinorrea, hace 2 días con fiebre y rinorrea mucopurulenta. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Amoxicilina por 10 días vía oral
B) Azitromicina por 5 días
C) Cotrimoxazol por 7 días
D) Tratamiento sintomático (suero fisiológico nasal)
E) Amoxicilina-clavulánico por 14 días

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Amoxicilina por 10 días vía oral** (opción **A**). Amoxicilina por 10 días vía oral. Sinusitis aguda viral: <7 dias o >7 dias pero mejorando; tratamiento sintomatico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 59 2.01.1.029 · Sinusitis

Un niño de 8 años presenta un cuadro de 14 días de congestión nasal con rinorrea purulenta, cefalea, sensación febril, asociada a odinofagia y tos con expectoración mucopurulenta. En los últimos días se agrega mayor malestar general y fiebre. Al examen físico presenta rinorrea purulenta abundante, descarga posterior y faringe congestiva y eritematosa, con examen pulmonar normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar tratamiento sintomático con paracetamol
B) Iniciar claritromicina oral
C) Iniciar ceftriaxona endovenosa
D) Iniciar amoxicilina oral
E) Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar amoxicilina oral** (opción **D**). Es una sinusitis aguda, que se trata con amoxicilina.. Sinusitis aguda viral: <7 dias o >7 dias pero mejorando; tratamiento sintomatico De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 73 2.01.5.004 · Maniobra de Heimlich

Un niño de 7 años, mientras estaba comiendo, presenta agitación súbita, asociada a imposibilidad de respirar. No puede toser, hablar ni llorar. ¿Cuál es la maniobra más adecuada en este momento?

A) Realizar respiración boca a boca
B) Meterle los dedos en la boca y retirar el cuerpo extraño
C) Dar golpes en la región interescapular
D) Abrazarlo por detrás y realizar compresiones subxifoideas
E) Realizar compresiones en el pecho, en decúbito supino

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Después de los 12 meses se hace la maniobra de Heimlich. Bajo los 12 meses de edad, se dan los golpes interescapulares.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 76 2.01.1.132 · Dismorfias

Un niño de 14 años, con antecedente de su padre, que murió de muerte súbita, presenta talla alta, sus dedos y extremidades son muy largos y algo desproporcionados. Además, presenta hiperlaxitud de las articulaciones y tiene un soplo diastólico cardíaco en la auscultación cardiopulmonar. ¿Cuál es el síndrome más probable?

A) Neurofibromatosis
B) Síndrome alcohólico fetal
C) Síndrome de Miller
D) Síndrome de Marfán
E) Síndrome de Ehler Dahnlos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un síndrome de Marfán clásico (afecta tanto a hombre, como a mujeres y es genético, autosómico dominante).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 115 2.01.1.031 · Anemia ferropriva

Un niño de 9 meses tiene palidez de piel y mucosas, por lo que se solicita un hemograma, que muestra hemoglobina: 9 g/dl, hematocrito: 36%, VCM: 68 fl, glóbulos blancos: 6.500 por mm3, plaquetas: 450.000 por mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Anemia ferropriva
B) Anemia por enfermedades crónicos
C) Trombocitosis esencial
D) Hemoglobinopatía
E) Microesferocitosis familiar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Anemia ferropriva** (opción **A**). Es una anemia ferropénica clásica, tanto por la edad, como por la microcitosis.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 69 2.01.1.031 · Anemia ferropriva

Lactante de 2 meses con hemograma: hemoglobina 10.2 g/dL, VCM normal, sin síntomas. La madre pregunta si debe iniciar suplemento de hierro. ¿Cuál es la explicación correcta?

A) Anemia fisiológica del lactante: normal, no requiere tratamiento
B) Anemia ferropénica: iniciar hierro elemental 2 mg/kg/día
C) Anemia hemolítica: solicitar Coombs directo
D) Anemia por déficit de folato: iniciar ácido fólico
E) Anemia aplásica: derivar a hematología

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Nadir fisiológico a los 2-3 meses: la Hb cae a 9.5-11 g/dL por dilución, disminución de eritropoyetina y destrucción de eritrocitos fetales. Es normal y no requiere tratamiento.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 36 2.01.1.031 · Anemia ferropriva

Niño hijo de madre vegana, solo pecho materno, con pancitopenia y macrocitosis en el frotis. ¿Diagnóstico más probable?

A) Déficit de vitamina B12
B) Anemia ferropénica
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Leucemia linfoblástica aguda
E) Déficit de ácido fólico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Déficit de vitamina B12** (opción **A**). Déficit de vitamina B12. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 106 2.01.1.031 · Anemia ferropriva

Un niño de 4 años, con antecedente de ictericia neonatal, que requirió fototerapia, es traído a la urgencia por dolor abdominal y náuseas de 4 días de evolución. Al examen físico destaca ictericia de piel y mucosas, asociado a palidez y en el examen abdominal se objetiva esplenomegalia, con bazo por 3 cm bajo el reborde costal. Su hemograma muestra hematocrito de 20%, hemoglobina de 6,9 g/dl, VCM: 70 fl, 17% de reticulocitos, blancos: 8.000 por mm3 y plaquetas: 200.000 por mm3. El frotis sanguíneo muestra macrocitosis, poiquilocitosis y anisocitosis. En sus pruebas hepáticas destaca bilirrubina 6 mg/dl, con bilirrubina directa de 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable:

A) Anemia hemolítica
B) Leucemia aguda
C) Anemia ferropénica
D) Anemia por déficit de vitamina B12
E) Anemia de Fanconi

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una anemia hemolítica, por el aumento de los reticulocitos, la hiperbilirrubinemia indirecta. El dolor abdominal y la esplenomegalia también son posibles. Lo tiene alteraciones en plaquetas ni glóbulos blancos, por lo que no es leucemia. El antecedente de ictericia neonatal no tiene mucha relevancia, aunque hay anemias hemolíticas de tipo genéticas, como la microesferocitosis hereditaria, que cursa con esplenomegalia y una clínica variable y que podría ser lo preguntado. El síndrome de Evans es una suma de púrpura trombopénico idiopático y anemia hemolítica autoinmune.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 154 2.01.1.031 · Anemia ferropriva

Un niño de 3 años, con antecedente de ictericia neonatal, que requirió fototerapia, es traído a la urgencia por dolor abdominal y náuseas de 4 días de evolución. Al examen físico destaca ictericia de piel y mucosas, asociado a palidez y esplenomegalia. Su hemograma muestra hematocrito de 19%, hemoglobina de 6,2 g/dl, con 23% de reticulocitos, blancos: 8.000 por mm3 y plaquetas: 200.000 por mm3. El frotis muestra macrocitosis, poiquilocitosis y anisocitosis. En sus pruebas hepáticas destaca bilirrubina 6 mg/dl, con bilirrubina directa de 0,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Anemia hemolítica
B) Leucemia aguda
C) Síndrome hemolítico urémico
D) Anemia por déficit de vitamina B12
E) Hepatitis aguda

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene todos los elementos de anemia hemolítica: elevación de los reticulocitos (es regenerativa), hiperbilirrubinemia indirecta y el clásico dolor abdominal, cuya fisiopatología no está muy clara. El SHU sí tiene hemólisis, pero, además, plaquetopenia y falla renal o compromiso del SNC. El antecedente de ictericia neonatal no aporta mucho, ya que parece una anemia autoinmune (por el poco tiempo de evolución), aunque existan anemias hemolíticas de tipo genético (que son crónicas y sí podrían haberse asociado a ictericia neonatal).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 133 2.01.1.025 · Laringitis

Un lactante de 12 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea y fiebre hasta 38,8°C de 24 horas de evolución, a lo que hoy se agregó dificultad respiratoria. Al examen físico presenta estridor inspiratorio, que aumenta con el llanto, asociado a retracción intercostal moderada. Su saturación de oxígeno es 94% y, al examen pulmonar se ausculta murmullo pulmonar conservado bilateral con transmisión de ruidos desde la vía aérea superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Laringitis aguda obstructiva
B) Neumonía atípica
C) Neumonía bilateral
D) Asma del lactante
E) Neumonitis viral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Laringitis Aguda Obstructiva: El caso describe una laringitis aguda obstructiva clásica, con un cuadro gripal seguido de síntomas obstructivos, incluyendo estridor laringeo.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 139 2.01.1.025 · Laringitis

Un niño de 18 meses presenta un cuadro de tos, rinorrea, disfonía y fiebre, hasta 38,5°C. Hace una hora presenta un cuadro de dificultad respiratoria, con respiración ruidos

A) Al examen físico se aprecia niño taquipneico, con estridor inspiratorio, uso de musculatura accesoria, sin cianosis. La auscultación pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:
A) Laringitis aguda viral
B) Croup espasmódico
C) Cuerpo extraño bronquial
D) Laringomalacia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (). Esta clase aborda la laringitis aguda y su variante obstructiva (crup viral). Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Al examen físico se aprecia niño taquipneico,, Laringitis aguda viral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 158 2.01.1.025 · Laringitis

Una niña de 3 años, previamente sana, presenta un cuadro de 2 días de evolución de rinorrea, asociada a fiebre de 39°C, con tos disfónica, a la que se agrega dificultad respiratoria hace una hora. Al examen físico, su frecuencia respiratoria es 48 por minuto, se escucha estridor inspiratorio y espiratorio y se objetiva retracción subcostal y supraesternal. La conducta inicial más adecuada es:

A) Administrar adrenalina subcutánea
B) Realizar nebulizaciones don salbutamol al 0,5%
C) Realizar intubación orotraqueal
D) Realizar nebulizaciones con bromuro de ipatropio al 0,5%
E) Realizar nebulizaciones con adrenalina racémica al 0,1%

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La laringitis obstructiva, se trata con O2, adrenalina racémica en nebulización y corticoides sistémicos (en ese orden de administración).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 162 2.01.1.117 · Estridor congénito

Un recién nacido de término presenta estridor desde el nacimiento, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, sin cianosis ni uso de musculatura accesoria. El diagnóstico más probable es:

A) Anillo vascular
B) Traqueomalacia
C) Laringomalacia
D) Hendidura laríngea
E) Fístula traqueoesofágica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Laringomalacia** (opción **C**). La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor congénito.. Esta clase aborda el estridor congenito, un tema breve pero importante en pediatria y otorrinolaringologia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 163 2.01.1.038 · Constipación

Un niño de 4 años presenta incontinencia fecal, en algunas ocasiones, desde hace dos meses. Sin embargo, en otras ocasiones, pasan muchos días sin defecar y cuando lo hace, sus deposiciones son duras y caprinas. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Niño sano
B) Atresia duodenal
C) Constipación funcional
D) Megacolon aganglionótico
E) Malrotación intestinal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una constipación funcional clásica, probablemente complicada con un fecaloma (por la incontinencia fecal). Es la causa más frecuente de constipación en niños y se mejora con laxantes y formación de hábitos de defecación.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 165 2.01.1.038 · Constipación

Un niño de 7 años desde hace 3 años presenta deposiciones cada vez más infrecuentes y duras. Hace algunas semanas empeoran los síntomas, por lo que se inicia lactulosa 15 ml al día, sin lograr cambios. Además, comienza a manchar frecuentemente los calzoncillos con deposiciones. La causa más probable de la falta de respuesta en este paciente es:

A) Dosis insuficiente de laxante
B) Dieta baja en fibra
C) Enfermedad de Hirschsprüng
D) Presencia de fecaloma
E) Concomitancia de patología psiquiátrica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La clínica es de un fecaloma clásico: constipación que progresa y luego tiene la pseudoincontinencia (incluso, a veces, hay encopresis). Se debe realizar un tacto rectal (en presencia de alguien más del centro médico, para no ser acusado de abuso, en especial hoy en día que abundan tanto los abusadores como las personas que acusan de abuso falsamente) y luego proceder a la desimpactación: con enema evacuante o solución oral. Una vez eliminado, se mantiene con laxantes por varias semanas. El polietilenglicol es lo más usado en pediatría.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 66 2.01.1.038 · Constipación

Una niña de 4 años acude al servicio de urgencia debido a que no ha defecado en 5 días. La madre refiere que recientemente presentó una infección viral en la que estuvo muy inapetente, rechazando la mayoría de los alimentos que se le ofrecían. Sin embargo, actualmente se encuentra de buen ánimo y con buen ape8to. Su examen Fsico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo en este momento?

A) Vaselina líquida por vía oral
B) Hidróxido de magnesio por vía oral
C) Enema evacuante de lactulosa
D) Polie2lenglicol 3350 vía oral
E) Gastroclisis con solución salina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una consGpación aguda funcional probablemente secundaria a disminución de la ingesta durante la infección viral. No Gene signos de complicación, por lo que el manejo de elección es la desimpactación por vía oral, siendo de elección el PEG 3350, por su eficacia y seguridad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 13 2.01.1.038 · Constipación

Niña 3 años con fisura anal resuelta, continua con constipación cual es el manejo adecuado:

A) Lactulosa
B) PEG (para desimpactar) sgy era aumentar consumo de fibra. Esq aumentar consumo de fibra va junto con aumentar consumo de agua
C) colonoscopía
D) Agua 2L e. Aumentar consumo de fibra
E) Control sano habitual

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **PEG (para desimpactar) sgy era aumentar consumo de fibra. Esq aumentar consumo de fibra va junto con aumentar consumo de agua** (opción **B**). Diarrea aguda (<2 semanas), prolongada (2-4 semanas), crónica (>=4 semanas); causas y manejo distintos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 53 2.01.1.075 · Hipotiroidismo

Un lactante de 3 meses, diagnosticado de hipotiroidismo congénito, en tratamiento con levotiroxina 25 mg/día. Se solicita TSH que resulta 0,09 UI/L (VN: 0,7 a 5,7) y T4 libre: 2,18 ng/dl (VN: 0,9 a 2,1). La conducta más adecuada es:

A) Suspender la levotiroxina
B) Subir la dosis de levotiroxina
C) Repetir la TSH en 6 semanas
D) Disminuir la dosis de levotiroxina
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene la TSH menor a lo normal, por lo que está "sobretratado" y se debe disminuir la dosis de levoT4. La habitual es 1,6 ug/Kg, así que probablemente estaba muy alta la dosis de 25 mg para un lactante de 3 meses (6 Kg aprox).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 88 2.01.1.075 · Hipotiroidismo

Un recién nacido es hijo de madre con hipotiroidismo, secundario a tratamiento con yodo radiactivo, por enfermedad de Basedow Graves, hace varios años. ¿Cuál es la conducta más adecuada para con el recién nacido?

A) Esperar el resultado del tamizaje de hipotiroidismo neonatal
B) Solicitar TSH y T4 libre a las 48 horas de vida
C) Solicitar TSH y T4 libre al nacer
D) Realizar ecografía tiroidea
E) Solicitar anticuerpos antitiroideos a los 15 días de vida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

[Pregunta disputada] La EBG, por ser autoinmune, con presencia de anticuerpos (los TRAB), tiene riesgo de pasar dichos anticuerpos al niño, incluso si es que la enfermedad está bien controlada. Por tanto, se produce un hiperT4 transitorio. Tanto la TSH y T4L como los niveles de TRAB deben solicitarse y se piden en varios momentos. De ellos, la función tiroidea es lo más importante y se piden a las 48 horas y también a los 15 días y en varios otros momentos. Al nacer pueden estar alterados por los valores maternos. Es una pregunta fuera de lugar y que no tiene una única respuesta.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 163 2.01.1.057 · Mesenquimopatías

Un niño de 12 años consulta por cansancio, artralgias, dolores musculares generalizados y fiebre. Refiere que las mialgias son intensas, al punto que limitan su actividad física. Al examen físico presenta dolor a la palpación de las masas musculares, en especial en la espalda alta y los hombros. Además, tiene eritema violáceo en los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:

A) Artritis reumatoide juvenil
B) Distrofia muscular
C) Dermatomiositis
D) Triquinosis
E) Lupus infantil

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una dermatomiositis infantil clásica, con el rash heliotropo y el rash en manto. Se debe descartar un cáncer (suele ser paraneoplásica).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 78 2.01.1.057 · Mesenquimopatías

Escolar femenina de 12 años con artritis en múltiples articulaciones, fotosensibilidad, úlceras orales, proteinuria 4 g/24h, hematuria microscópica y ANA positivo 1:640. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Lupus eritematoso sistémico
B) Artritis idiopática juvenil
C) Dermatomiositis juvenil
D) Vasculitis sistémica
E) Enfermedad de Kawasaki

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

LES: artritis + fotosensibilidad + úlceras orales + nefritis lúpica (proteinuria >3.5g + hematuria) + ANA positivo en patrón homogéneo. Cumple criterios SLICC para diagnóstico.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 167 2.01.1.103 · Rinitis alérgica

Un niño de 4 años consulta por infecciones recurrentes, habiendo tenido una otitis media aguda, 2 bronquitis y 3 amigdalitis en el último año. Presenta rinorrea con frecuencia, obstrucción nasal, respira por la boca y ronca en la noche. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rinitis alérgica
B) Inmunodeficiencia primaria por déficit de inmunoglobulinas
C) Hipertrofia de adenoides
D) Fibrosis quística
E) Enfermedad de cilio inmóvil

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La rinitis alérgica es la causa más frecuente de obstrucción nasal, rinorrea y respiración bucal en pediatría. La HT de adenoides sí tiene infecciones recurrentes y obstrucción, aunque le sobra la rinorrea. La B, D y E tendrían infecciones bacterianas, sin obstrucción nasal y la D y E tienden a hacer neumonías, mientras que la B sí hace neumonías, pero también las otitis y sinusitis. El número de infecciones recurrentes del paciente no alcanzan a ser realmente infecciones recurrentes.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 36 2.01.2.144 · SARS Cov 2 COVID 19

Un adolescente de 14 años presenta un cuadro de fiebre de 39ºC, desde hace 3 días, asociado a malestar general, dolor abdominal, vómitos y diarrea, seguido de marcado compromiso, por lo que acude al servicio de urgencia. Al examen físico está con compromiso hemodinámico, con frecuencia cardíaca de 120x' y PA: 90/50 mmHg, por lo que que es manejado con suero fisiológico endovenoso, con respuesta parcial. Tiene antecedente de PCR positiva para Covid-19 hace 30 días y se solicitan nuevos exámenes, que muestran hematocrito: 33%, blancos: 14.000 por mm3, plaquetas: 80.000 por mm3, VHS: 76 mmHg, PCR: 15,5 mg/L, dímero D: 670 ng/ml y troponinas elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sepsis bacteriana
B) Síndrome inflamatorio multisistémico
C) Insuficiencia suprarrenal aguda
D) Reinfección por Covid-19
E) Enfermedad de Kawasaki

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome inflamatorio multisistémico** (opción **B**). La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, el cual no debe confundirse con el SARS-CoV-1 responsable del antiguo síndrome respiratorio agudo severo. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 59 · 2.01.5.011 · Reanimación neonatal

Un recién nacido de término nace deprimido, con apnea y frecuencia cardíaca de 40 la8dos por minuto. Se es8mula, se administra oxígeno y se inician ven8laciones a presión posi8va. Se reevalúa a los 30 segundos, manteniéndose la frecuencia cardíaca en el mismo valor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar adrenalina por vía endovenosa
B) Realizar intubación orotraqueal
C) Con2nuar con ven2lación a presión posi2va y reevaluar en 30 segundos
D) Aumentar la presión de ven2lación y reevaluar en 30 segundos
E) Iniciar compresiones torácicas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

En la reanimación neonatal se reevalúa cada 30 segundos (en adultos es cada 2 minutos). El orden es el siguiente: 1. EsGmular (secar, calor, aspirar secreciones, vía aérea y oxígeno), 2. VPP (hasta FC > 100 y respire bien, sin apnea ni gasping), 3. Compresiones torácicas (si FC < 60 a pesar de VPP y, desde antes, si es que está en paro) y 4. Adrenalina, etc. En este caso, no estaba en paro, así que solo se iniciaba la ventilación a presión positiva (por la apnea y la FC < 100), pero, por mantenerse la FC bajo 60, a pesar de la VPP, se debe agregar el masaje cardíaco.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 57 · 2.01.5.011 · Reanimación neonatal

Un recién nacido nace por cesárea de urgencia, debido a un registro fetal con signos de hipoxia. Al examen físico tiene cianosis generalizada e hipotonía, sin esfuerzo respiratorio, por lo que se seca y se pone bajo calor radiante, en posición de olfateo, con aporte de oxígeno. A los 50 segundos persiste en apnea y se constata pulso carotideo a 30 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Conectar a ventilación mecánica
B) Administrar bicarbonato endovenoso
C) Administrar adrenalina por vía orotraqueal
D) Dar ventilación a presión positiva con mascarilla facial
E) Realizar masaje cardíaco

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Después de 30 segundos de estimulación, la reanimación neonatal comienza con VPP, hasta que sus latidos sean mayores de 100x' y respire solo. El masaje cardíaco se indica si está en paro cardíaco o si la FC está bajo 60 latidos por minutos, a pesar de la VPP.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 151 · 2.01.5.011 · Reanimación neonatal

Una paciente de 26 años, cursando un embarazo de 41 semanas, inicia trabajo de parto. Al examen tienen 4 contracciones cada 10 minutos, dilatación cervical de 6 cm El registro fetal muestra desaceleraciones variables. Al romperse las membranas sale meconio espeso. El nacimiento se produce algunos minutos después, obteniéndose un recién nacido hiporreactivo e hipotónico. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Poner bajo calor radiante, administrar oxígeno, secar y reevaluar en 30 segundos
B) Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea
C) Realizar ventilación a presión positiva
D) Realizar compresiones torácicas
E) Aspirar el contenido gástrico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar intubación orotraqueal y aspirar la vía aérea** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 2 · 2.01.5.011 · Reanimación neonatal

Recién nacido de término con diagnóstico prenatal de hernia diafragmática izquierda. Al nacer presenta cianosis, dificultad respiratoria severa y abdomen excavado. ¿Cuál es la maniobra inicial más importante?

A) Ventilación con bolsa-mascarilla
B) Aspiración orofaríngea
C) Oxígeno por cánula nasal
D) Intubación orotraqueal inmediata
E) CPAP nasal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hernia diafragmática: la ventilación con bolsa-mascarilla está CONTRAINDICADA (distensión intestinal comprime el pulmón). Se debe intubar de inmediato para ventilar con presiones bajas y descomprimir la vía aérea.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 9 · 2.01.5.011 · Reanimación neonatal

Recién nacido hipotónico, poco reactivo, cianótico, con meconio espeso. ¿Cuál debe ser la conducta inicial?

A) Poner en calor radiante, aspirar vía aérea superior y estimular
B) Intubación orotraqueal inmediata
C) Ventilación con presión positiva de inmediato
D) Compresiones torácicas y adrenalina
E) Aspirar meconio con sonda y ventilar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Poner en calor radiante, aspirar vía aérea superior y estimular** (opción **A**). Poner en calor radiante, aspirar vía aérea superior y estimular. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 56 · 2.01.5.011 · Reanimación neonatal

Una mujer de 23 años está en trabajo de parto. Al momento de romperse las membranas, se observa salida de meconio espeso. El recién nacido nace cianótico, hipotónico, sin esfuerzos respiratorio. La conducta inicial debe ser:

A) Aspirar vía aérea con sonda
B) Dar ventilación a presión positiva
C) Administrar adrenalina endotraqueal
D) Realizar intubación orotraqueal
E) Realizar masaje cardíaco

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta bastante difícil, ya que la regla general de la reanimación neonatal en un niño cianótico, hipotónico y sin esfuerzo respiratorio sería estimular, dar oxígeno y rápidamente iniciar ventilaciones a presión positiva. Sin embargo, el antecedente de meconio obliga a aspirarlo de la vía aérea antes de ventilar. Sobre el líquido meconial vale la pena precisar lo siguiente: 1. No se aspira la boca al momento de salir la cabeza, sino una vez que el niño ha salido. 2. No se aspira la tráquea si el niño nace vigoroso, sino solo la orofaringe. 3. Solo se aspira si es que el niño nace deprimido y con meconio, y en ese caso, se aspira como medida inicial, para evitar la aspiración del meconio (que aumenta con la VPP). Se puede aspirar con una sonda o por medio del tubo endotraqueal, el que se prefiere si es que está deprimido (no vigoroso), por lo que la respuesta D también parece correcta. Sin embargo, dado que lo principal es la aspiración, elegimos la aspiración con sonda, por sobre la intubación.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 49 2.01.5.011 · Reanimación neonatal

RN de término con líquido amniótico meconial espeso. Al nacer llora vigoroso, frecuencia cardíaca 130 lpm, buen tono muscular. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Intubación y aspiración traqueal inmediata
B) Manejo de rutina: contacto piel a piel, no aspirar si vigoroso
C) Aspiración orofaríngea con pera de goma
D) Oxígeno por mascarilla al 100%
E) Hospitalización en UCI neonatal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

RN con meconio pero vigoroso (llanto, FC>100, buen tono): no se realiza intubación ni aspiración traqueal. Manejo de rutina. La aspiración rutinaria en RN vigoroso no mejora resultados (guías NRP 2020).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 8 2.01.1.128 · RN PEG-GEG

Recién nacido pequeño para la edad gestacional (2.500 g). ¿Qué conducta tomar en relación a la alimentación?

A) Iniciar fórmula láctea hipercalórica
B) Instalar sonda nasogástrica para alimentación
C) Ayuno 6 horas y luego fórmula de prematuro
D) Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas
E) Suero glucosado al 10% endovenoso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas** (opción **D**). Pecho materno precoz y control de glicemia a las 2 horas. RN pretérmino <37 sem, término 37-41+6, postérmino ≥42 semanas de gestación De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 73 2.01.1.128 · RN PEG-GEG

Una niña nace por parto vaginal de término. Su peso al nacer es 2.500 gramos, que es menor al percentil para la edad gestacional. Su Apgar fue 9-9-10, observándose enflaquecida, pero vigorosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la alimentación?

A) Administrar suero glucosado al 5% endovenoso y controlar glicemia en 2 horas
B) Administrar suero glucosado al 5% oral
C) Alimentar con fórmula láctea hasta que la madre produzca leche
D) Dar fórmula láctea después de cada toma de leche materna
E) Alimentar inmediatamente al pecho materno y solicitar glicemia a las 2 horas de vida

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Administrar suero glucosado al 5% oral** (opción **B**). RN pretérmino <37 sem, término 37-41+6, postérmino ≥42 semanas de gestación De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 10 2.01.1.128 · RN PEG-GEG

¿Cuál es la complicación más probable en un recién nacido pequeño para la edad gestacional (2.500 g) de término en las primeras horas?

A) Hiperbilirrubinemia
B) Hipocalcemia
C) Policitemia
D) Sepsis neonatal
E) Hipoglicemia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Hipoglicemia). Hipoglicemia. :::tip Las 4 complicaciones graves (EMH, ECN, hemorragia periventricular, muerte) se pueden prevenir con corticoides antenatales en el manejo del parto prematuro. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 71 2.01.1.128 · RN PEG-GEG

Un recién nacido nace por parto vaginal a las 40 semanas y pesa 2.600 gramos. ¿Cuál de las siguientes complicaciones se presentará con mayor riesgo en las primeras horas de vida?

A) Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido
B) Hiperbilirrubinemia
C) Anemia
D) Hiperkalemia
E) Hipoglicemia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es pequeño para la edad gestacional (a las 40 semanas el promedio de peso al nacer es 3.500 gramos). En las primeras horas el riesgo más alto es la hipoglicemia. Además, los PEG no tienen riesgo de anemia, sino de poliglobulia ni de distrés respiratorio.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 27 2.01.1.128 · RN PEG-GEG

Alteración metabólica que se debe buscar en PEG

A) Hiperglucemia
B) hipercalcemia c. Anemia d. Poliglobulia (la poliglobulia no era más de GEG?)
E) Trombocitosis
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (hipercalcemia c. Anemia d. Poliglobulia (la poliglobulia no era más de GEG?)). :::tip Las 4 complicaciones graves (EMH, ECN, hemorragia periventricular, muerte) se pueden prevenir con corticoides antenatales en el manejo del parto prematuro. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 21 2.01.2.022 · Quemaduras

Usted atiende a un niño de 3 años en el servicio de urgencia, que es traído por su madre, por haber sufrido quemaduras en los dedos y en la espalda, después de haberse apoyado accidentalmente en una estufa. Al examen físico, está agitado y llorando y se observa eritema y flictenas en las zonas afectadas. ¿Cuál es la conducta inicial?

A) Curaciones
B) Paracetamol vía oral
C) Ungüento antibiótico tópico
D) Analgesia endovenosa
E) Antibióticos endovenosos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Analgesia endovenosa** (opción **D**). Tratamiento De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Curaciones, Paracetamol vía oral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 153 2.01.1.018 · Síndrome febril prolongado

Un niño de 5 años presenta fiebre desde hace 7 días, que ha respondido parcialmente al uso de an8piré8cos. Al examen Fsico se palpa una adenopa`a cervical de 1,5 cm y en el examen abdominal se palpa esplenomegalia. Se solicita ecograFa abdominal que muestra múl8ples lesiones hipoecogénicas de pequeño tamaño en hígado y bazo, compa8bles con microabscesos, sin pared visible. ¿Cuál es el agente e8ológico más probable?

A) Citomegalovirus
B) Virus de Epstein-Barr
C) Bartonella henselae
D) Echinococcus granulosus
E) Mycobacterium tuberculosis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una enfermedad por arañazo de gato clásica, con la fiebre, adenopaVa y compromiso hepatoesplénico. Eso sí, la presentación más frecuente es con fiebre más una o más adenopaVas en relación a una lesión cutánea. La igM anti-Bartonella puede ser úGl para confirmar el diagnóstico. El tratamiento de elección son los macrólidos (azitromicina).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 53 2.01.1.018 · Síndrome febril prolongado

Un niño de 4 años lleva 9 días con fiebre, sin otros síntomas. Al examen físico tiene T° 38,5°C, se palpan adenopatías submandibulares y en el examen abdominal se palpa el hígado 2 cm bajo el reborde costal. Se solicita una ecografía abdominal, que muestra múltiples imágenes, compatibles con granulomas hepatoesplénicos vascularizados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Infección por virus de la inmunodeficiencia humana
B) Infección por Barthonella henselae
C) Infección por virus de Epstein Baar
D) Enfermedad de Kawasaki
E) Brucelosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Infección por virus de la inmunodeficiencia humana** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 46 2.01.3.002 · Desarrollo psicomotor

Madre consulta por evaluación de desarrollo de su hijo de 1 año y 3 meses. El niño camina solo, dice 3 palabras con significado y construye una torre de 3 cubos. ¿Cómo se interpreta su desarrollo psicomotor?

A) Retraso en el lenguaje
B) Retraso en el área motora
C) Desarrollo normal para su edad
D) Retraso global del desarrollo
E) Requiere evaluación neurológica urgente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hitos normales a los 15 meses: marcha independiente (esperada a 12 m) ✓, 3-5 palabras (esperadas 12-15 m) ✓, torre de 2 cubos (esperada 15 m, torre 3 cubos es adelantado) ✓. Desarrollo completamente normal. Control de salud infantil de rutina.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 25 2.01.3.002 · Desarrollo psicomotor

Niño de 9 meses que gatea, toma cubos con pinza intermedia, dice bisílabos, se incomoda con extraños. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Retraso global del desarrollo
B) Desarrollo normal
C) Retraso del lenguaje
D) Trastorno del espectro autista
E) Retraso motor leve

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Desarrollo normal** (opción **B**). Desarrollo normal. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 128 2.01.3.002 · Desarrollo psicomotor

Un lactante de 4 meses de vida, con antecedente de haber nacido prematuro a las 34 semanas, es capaz de levantar la cabeza y llevar las manos al centro. Sin embargo, no puede levantar el tronco apoyado en los antebrazos ni pasar objetos de una mano a la otra. Al interactuar con una persona sonríe, pero no ríe a carcajadas. Sigue con la mirada los objetos. Como antecedente, se alimenta con lactancia materna exclusiva. ¿Cuál es su diagnós8co respecto al desarrollo psicomotor?

A) Retraso motor fino
B) Retraso motor grueso
C) Retraso del desarrollo socioemocional
D) Retraso global del desarrollo
E) Desarrollo psicomotor normal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por haber nacido prematuro, se recomienda ajustar la edad para evaluar el desarrollo psicomotor. Se ajusta respecto de las 40 semanas, por lo que se considera 6 semanas menor, con edad corregida de 2,5 meses. De los hitos mencionados, cumple los de los 2 meses (levantar la cabeza, llevar manos al centro, sonrisa social) y no los de los 4 meses (reír a carcajadas, levantar tronco apoyado, pasar objetos de una mano a la otra), lo que es normal.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 80 2.01.3.002 · Desarrollo psico-motor

Un niño de 9 meses, acude a control. Al interrogar a la madre y evaluar el desarrollo psicomotor, se obtiene que dice disílabos, pero ninguna palabra; gatea, pero no da pasos con apoyo; toma objeto con las manos, utilizando una pinza intermedia; desconfía de los extraños y presenta ansiedad de separación. ¿Cuál es el diagnóstico desde el punto de vista de su desarrollo psicomotor?

A) Retraso del desarrollo psicomotor
B) Parálisis cerebral
C) Trastorno global del desarrollo
D) Discapacidad cognitiva
E) Desarrollo psicomotor normal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Discapacidad cognitiva** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 115 2.01.1.096 · Estrabismo

Un lactante de 1 mes de vida, acude a control. Al examen físico, presenta estrabismo intermitente y asimétrico de ambos ojos. El resto de la inspección ocular es normal. Su crecimiento pondoestatural es normal, al igual que su desarrollo psicomotor y el resto de su examen físico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a oftalmólogo
B) Mantener los controles habituales del lactante
C) Solicitar RMN de cerebro
D) Realizar fondo de ojo
E) Indicar parche ocular alternante

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener los controles habituales del lactante** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 26 2.01.1.096 · Estrabismo

Niño de 1 mes con desviación de la mirada de manera intermitente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a oftalmología de urgencia
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Mantener controles habituales de niño sano
D) Iniciar parche ocular
E) Solicitar fondo de ojo urgente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener controles habituales de niño sano** (opción **C**). Mantener controles habituales de niño sano. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 20 2.01.1.088 · Criptorquidia

Recién nacido de término sin testículos palpables, pene de 2 cm. Además de solicitar ecografía, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a urología de inmediato
B) Control en un mes
C) Iniciar testosterona tópica
D) Derivar a genética para cariotipo urgente
E) Cirugía correctiva a los 3 meses

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Control en un mes** (opción **B**). Control en un mes. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 116 2.01.1.088 · Criptorquidia

Usted evalúa a un recién nacido de término, que está en buenas condiciones, se alimenta con leche materna y tiene examen neurológico normal. Al examen físico segmentario no se palpa ninguno de los testículos en el escroto ni en la zona inguinal. Su pene mide 2 cm de largo. Además de solicitar una ecografía inguinal, la conducta más adecuada es:

A) Controlar en un mes
B) Solicitar niveles plasmáticos de testosterona
C) Realizar exploración quirúrgica en este momento, mediante laparoscopía
D) Solicitar cariograma
E) Planificar cirugía de descenso testicular al cumplir un año

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar cariograma** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Controlar en un mes, Solicitar niveles plasmáticos de testosterona) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 12 2.01.1.056 · Inmunodeficiencias

Niño que después de los 6 meses presenta candidiasis bucal, otitis media recurrente y 2 neumonías hospitalizadas. ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable?

A) Inmunodeficiencia celular (DiGeorge)
B) Déficit de complemento
C) Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)
D) Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
E) Enfermedad granulomatosa crónica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia)). Inmunodeficiencia humoral (agammaglobulinemia). Prevención de transmisión vertical (madre VIH+): 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 136 · 2.01.1.056 · Inmunodeficiencias

Un lactante de 15 meses fue sano hasta los 6 meses de edad, pero, después de ello, ha presentado candidiasis oral a repetición, cuatro otitis medias aguda y dos neumonías que han requerido hospitalización. ¿Cuál es la causa más probable de su inmunodepresión?

A) Inmunodeficiencia humoral
B) Inmunodeficiencia combinada severa
C) Alteración de la fagocitosis
D) Déficit de complemento
E) Inmunodeficiencia celular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Inmunodeficiencia humoral). Prevención de transmisión vertical (madre VIH+): 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Inmunodeficiencia combinada severa, Alteración de la fagocitosis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 150 · 2.01.1.120 · Hipoglicemia

Un recién nacido de término, con antecedente de madre con preclamsia, pesa 2.600 gramos al nacer. ¿Cuál es la complicación más frecuente durante las primeras horas de vida?

A) Hipoglicemia
B) Sepsis
C) Hiperbilirrubinemia
D) Anemia
E) Distrés respiratorio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Hipoglicemia). :::warning El prematuro NO produce poliglobulia → produce anemia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Sepsis, Hiperbilirrubinemia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 155 · 2.01.1.071 · Trastornos hidro-electrolí

Un niño de 6 años fue operado de un tumor cerebral hace 7 días. Desde entonces ha presentado volúmenes urinarios aumentados, de 4,5 litros al día. Se solicitan exámenes de sangre, que muestran glicemia de ayuno: 103 mg/dl, Na+: 154 mEq/L, K+: 4,9 mEq/L. Orina con sedimento normal, densidad 1.005 g/L y osmolaridad urinaria: 100 mOsm/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome perdedor de sal cerebral
B) Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
C) Insuficiencia suprarrenal
D) Diabetes insípida
E) Diabetes mellitus

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Diabetes insípida** (opción **D**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 11 · 2.01.4.003 · Ecotomografía abdominal

Recién nacido de 4-5 semanas con vómitos postprandiales lácteos, enflaquecido y deshidratado. ¿Cuál es el examen inicial para el estudio?

A) Radiografía de abdomen simple
B) Ecografía abdominal
C) TAC de abdomen con contraste
D) Endoscopía digestiva alta
E) Tránsito esofagogastroduodenal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Ecografía abdominal). Ecografía abdominal. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Radiografía de abdomen simple, TAC de abdomen con contraste) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 18 · 2.01.1.030 · Adenopatías

Niño con adenopatías cervicales y granulomas hepatoesplénicos en la ecografía abdominal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Bartonella henselae
B) Toxoplasma gondii
C) Epstein-Barr virus
D) Mycobacterium tuberculosis
E) Leishmania sp.

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Bartonella henselae). Bartonella henselae. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Toxoplasma gondii, Epstein-Barr virus) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 5 · 2.01.1.030 · Adenopatías

Niño adenopatía, fiebre, lesiones focales esplénicas a. Estudio bartonella henselae

A) Control sano habitual
B) Derivar a especialista
C) Hospitalizar
D) Observación domiciliaria
E) Iniciar tratamiento empírico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Control sano habitual). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Derivar a especialista, Hospitalizar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 21 2.01.1.089 · Fimosis

Niño de 3 años con prepucio estrecho, con control de esfínteres hace 6 meses. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Circuncisión inmediata
B) Aplicar corticoide tópico
C) Control en un año
D) Dilatación manual bajo anestesia
E) Derivar a urología pediátrica urgente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Control en un año** (opción **C**). Control en un año. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 23 2.01.1.013 · Infecciones por Salmonella

Niño con fiebre de 10 días, cefalea, mialgias, diarrea y luego heces duras, hígado y bazo palpables. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar estudio?

A) Coproparasitológico seriado
B) Coprocultivo
C) Serología para Epstein-Barr
D) Hemocultivo
E) Prueba de Widal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Hemocultivo). Hemocultivo. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Coproparasitológico seriado, Coprocultivo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 137 2.01.1.013 · Infecciones por Salmonella

Pediátrico, 2 días de dolor abdominal, diarrea líquida 10-15 episodios/día, 3 máculas que blanquean a la presión en abdomen, hepatomegalia, hemograma con Eosinofilos en 0, Anemia, coprocultivo negativo.

A) Salmonella tiphy
B) Campylobacter
C) Salmonella enteritidi
D) Shigella
E) E. Coli entero hemorrágica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Salmonella tiphy). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Campylobacter, Salmonella enteritidi) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 26 2.01.1.115 · Convulsiones neonatales

RN de término convulsión a las 12 hrs de 2 minutos de duración. A la evaluación todo normal hgtes: diagnóstico más probable

A) Epilepsia
B) Hipoglicemia
C) Hipocalcemia
D) Hemorragia intracerebral
E) Accidente cerebrovascular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Hipoglicemia** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Epilepsia, Hipocalcemia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 29 2.01.1.049 · Arritmias

Lactante con FC 280 lpm regular, soporoso, pulsos femorales disminuidos, no se puede medir PA. ¿Cual es la conducta?:

A) Cardioversión
B) Adenosina
C) Maniobras vasovagales (PORQUE NO PUEDE SER ESTA DE MANERA INICIAL???) - pulsos disminuidos se puede interpretar como compromiso HDN... ademas maniobras vagales requieren que el pcte coopere y tenia como 2 años
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Cardioversión** (opción **A**). SHU: E.coli O157:H7 (STEC); tríada IRA + anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia; NO antibióticos De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 122 2.01.1.123 · Prematurez

Qué leche le das a un RN prematuro que ya tiene 12 meses:

A) Fórmula 3 de continuación (se da formula prematuros hasta el año de edad corregida)
B) leche de vaca
C) Fórmula para prematuros
D) Leche semidescremada
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Fórmula 3 de continuación (se da formula prematuros hasta el año de edad corregida)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 42 2.01.1.125 · Síndrome aspirativo meconi

Una paciente de 42 años, embarazada de término ingresa en trabajo de parto. Durante el expulsivo aparecen múltiples desaceleraciones tardías en el registro cardiaco fetal y el líquido amniótico se tiñe de meconio. El recién nacido nace hipotónico, cianótico y no reactivo, con meconio espeso. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Aspirar la boca del recién nacido ante la salida de la cabeza por el canal de parto, antes de su expulsión completa

B) Realizar intubación orotraqueal y aspirar secreciones traqueales antes de que el recién nacido llore

C) Realizar intubación orotraqueal y conectar al ventilador mecánico invasivo

D) Secar, poner en calor radiante, administrar oxígeno y estimular al recién nacido

E) Administrar adrenalina endovenosa

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo del Recién Nacido con Meconio: El manejo ha cambiado. Si el recién nacido está vigoroso, no se necesita un manejo diferente al de un recién nacido. Si nace deprimido y con meconio, las recomendaciones antiguas eran intubar y aspirar las secreciones con meconio antes de la reanimación. Actualmente, las recomendaciones internacionales indican proceder directamente a la reanimación estándar.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 47 2.01.1.047 · Síndrome disentérico

Un niño de 14 años, con antecedente de síndrome de QT largo, con historia familiar positiva, consulta por cuadro de fiebre, dolor abdominal y deposiciones líquidas de 5 de evolución, persistentes, que hace dos días se han vuelto sanguinolentas. Además de la hidratación, ¿qué antibiótico debe indicarse?

A) Ciprofloxacino

B) Azitromicina

C) Metronidazol

D) Sulfametoxazol con trimetoprim

E) Ampicilina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Antibiótico y QT largo: Las disenterías se pueden tratar con antibióticos que cubran Shigella y otras enterobacterias. El ciprofloxacino, la azitromicina y el sulfametoxazol con trimetoprim son opciones aceptables, al igual que las cefalosporinas orales. En casos graves, se pueden usar cefalosporinas endovenosas. En el síndrome de QT largo, el ciprofloxacino y la azitromicina están contraindicados. De las opciones, solo el sulfametoxazol con trimetoprim sería adecuado. El metronidazol cubre anaerobios, no los gramnegativos. La ampicilina puede cubrir algunas enterobacterias, pero su espectro es insuficiente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 100 2.01.1.060 · Hematuria

Un niño de 7 años se encuentra en el preoperatorio para una cirugía de fimosis. Se solicitan múltiples exámenes prequirúrgicos, entre los que se observa un examen de orina que reporta: 2-5 leucocitos por campo, 10-15 eritrocitos por campo y proteínas de 5 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar la determinación del índice albúmina/creatinina en orina

B) Solicitar la determinación de creatinina y calcio en una muestra de orina aislada

C) Repetir el examen de orina

D) Solicitar proteinuria en orina de 24 horas

E) Solicitar títulos de antiestreptolisina O

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Microhematuria Aislada en Niños: Un sedimento de orina muestra microhematuria. Los leucocitos y las proteínas están dentro del rango normal. El manejo de la microhematuria aislada en un niño generalmente consiste en repetir los análisis de orina. Si la microhematuria persiste, se realiza un estudio completo para descartar glomerulonefritis y, luego, hematuria de origen urológico. Si al inicio hubiera leucocituria junto con la hematuria, se estudiaría como una infección urinaria. Si al inicio hubiera proteinuria junto con la hematuria, se estudiaría como una glomerulonefritis.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 148 2.01.2.023 · Shock

Una lactante de 2 meses de edad presenta un cuadro de fiebre hasta 39°C, de 24 horas de evolución. Es llevada al servicio de urgencias debido a que ha evolucionado con deterioro del estado general y tendencia a la letargia. Al examen físico se observa soporosa, con un llenado capilar de 5 segundos, deshidratada y taquicárdica a 158 latidos por minuto. La temperatura es de 39,3°C. Además de administrar oxígeno, ¿cuál es la primera medida a tomar?

A) Administrar solución fisiológica por vía endovenosa

B) Administrar bicarbonato por vía endovenosa

C) Administrar adrenalina por vía endovenosa

D) Administrar hidrocortisona por vía endovenosa

E) Administrar glucosa por vía endovenosa

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de Sepsis en Lactantes: En casos de sepsis en lactantes, la prioridad es la reanimación y la administración de antibióticos. Si el lactante presenta shock o signos de deshidratación, la primera medida es la hidratación intravenosa con solución salina.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 160 2.01.1.001 · Desnutrición

Un niño de 5 años presenta bajo incremento ponderal, con talla y peso menores a -1 desviación estándar para su edad. Se observa una radiografía de mano, que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Raquitismo

B) Displasia ósea

C) Osteogénesis imperfecta

D) Osteomalacia

E) Osteoporosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Raquitismo: La radiografía muestra un retraso severo en la calcificación de los huesos del carpo y otros huesos de la mano, lo que es compatible con raquitismo causado por deficiencia de vitamina D.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 34 2.01.1.092 · Displasia de caderas

Una lactante de 2 meses, alimentada con lactancia materna exclusiva y con adecuado incremento ponderal, presenta en su examen Fsico signo de Ortolani y limitación en la abducción de la cadera derecha. No 8ene antecedentes familiares de importancia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecogra:a de caderas
B) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de caderas
C) Indicar doble pañal y control en un mes
D) Realizar radiogra:a anteroposterior de pelvis de ru2na a los 3 meses
E) Realizar cirugía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La ecografía de cadera es el examen de elección para el diagnóstico de displasia de cadera y se puede hacer desde el nacimiento. Desde los 4 meses, la radiografía AP de pelvis pasa a ser de elección. Eso sí, en Chile, se usa la radiografía como screening a los 3 meses. Cuando hay alteraciones en el examen físico (como en este caso) se deben tomar dos medidas urgentes: 1. Derivar de inmediato a traumatología infantil y 2. Solicitar la imagen confirmatoria (ecografía en este caso, por la edad).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 58 2.01.1.034 · Neutropenia febril

Un niño de 7 años, diagnos8cado de leucemia linfoblás8ca aguda, inicia sus ciclos de quimioterapia hace 7 días. Consulta por fiebre asociada a malestar general. Al examen Fsico presenta temperatura 38,5 °C y frecuencia cardíaca 110 x minuto, sin alteraciones en el examen Fsico segmentario. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar cejriaxona intramuscular y controlar en 24 horas
B) Indicar an2piré2cos y controlar en caso de persistencia de la fiebre
C) Administrar an2bió2cos de amplio espectro por vía endovenosa
D) Solicitar serología para virus de Epstein-Barr y citomegalovirus
E) Iniciar amoxicilina por vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una neutropenia febril, que es una urgencia infectológica y que requiere administrar an<bió<cos endovenosos de amplio espectro, con cobertura an<-Pseudomonas (ej, cefepime, imipenem o piperacilina/tazobactam en ocasiones más aminoglicósidos: tobramicina o amikacina), durante la primera hora. Además, se deja cobertura para gran positivos si es que hay riesgo (ej. lesiones cutáneas, catéteres, etc.), con vancomicina. Si lleva mucho Gempo o hay sospecha, se cubren hongos. Además, se piden muchos exámenes, en búsqueda del foco infeccioso. En las neutropenias febriles de bajo riesgo (sin neoplasia hematológica, con neutropenia sobre 200 por mm3, sin foco infeccioso, con buen estado general y en que se espera que la neutropenia dure menos de 7 días), se puede tratar con antibióticos orales (ej. ciprofloxacino más amoxicilina con ácido clavulánico).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 96 2.01.1.087 · Tumores SNC

Un niño de 9 años, con antecedente de neurofibromatosis 8po 1, consulta por proptosis izquierda de 6 meses de evolución, progresiva e indolora. Tiene examen visual realizado a los 6 años normal. Actualmente se observa proptosis izquierda leve, con disminución de la visión de colores del ojo izquierdo y agudeza visual 20/25 en el ojo derecho y 20/30 en el ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Celuli2s orbitaria
B) Re2noblastoma
C) Orbitopaaa dis2roidea
D) Angiolipoma orbitario
E) Tumor del nervio óp2co

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La NF1 se asocia a gliomas ópticos y a otros tumores (neurofibromas cutáneos y plexiformes, además de algunos tumores malignos). La afectación de la visión de colores orienta a patología del nervio óptico. El cuadro clínico con proptosis progresiva unilateral orientaba a un tumor. Aunque rara, no es una pregunta difícil.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 100 2.01.1.112 · Alteraciones de la termorr

Un recién nacido de término, de 37 semanas de gestación y peso de 2.900 g, presenta temperatura corporal de 35,5 °C sin otras alteraciones. Se realiza secado de la piel del recién nacido y se indica contacto directo piel con piel con su madre; sin embargo, persiste con temperatura en dicho rango. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Poner en incubadora a 38 °C
B) Poner en incubadora precalentada y realizar ajuste progresivo de la temperatura
C) Poner en cuna con calor radiante, sin ropa ni cobertor
D) Administrar suero glucosado al 10% por vía endovenosa
E) Cubrir al recién nacido con mantas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Aunque varía según la fuente, la hipotermia neonatal se suele definir como temperatura menor a 36,5 °C. Se clasifica en: Leve: 36 a 36,4 °C. Se maneja con medidas generales como abrigo, contacto piel con piel y alimentación precoz. Moderada: 32-35,9 °C. Si fracasan las medidas generales, se debe administrar calor, siendo de elección la incubadora, la que debe estar precalentada y con ajuste progresivo de la temperatura. Si no está disponible, es aceptable el calor radiante. Grave: <32 °C. Además, se maneja en UCI neonatal, de forma agresiva.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 3 2.01.1.090 · Hernia inguinal

Recién nacido de 3 días con protuberancia blanda en la línea media abdominal, de 1 cm de diámetro, reductible, sin signos inflamatorios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cirugía electiva inmediata
B) Cirugía de urgencia
C) Derivación a cirugía pediátrica urgente
D) Antibióticos profilácticos
E) Observación: la mayoría se cierra espontáneamente antes de los 4 años

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Hernia umbilical en RN: es fisiológica y se cierra espontáneamente en el 90% de los casos antes de los 4 años. No requiere cirugía ni antibióticos. Solo observar; cirugía si persiste después de los 4-5 años o si se complica.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 25 · 2.01.1.078 · Encefalopatía hipóxico-isq

RN por parto distocico y que requirió reanimación, presenta astenia, hipotonía y otros síntomas horas después

A) Sepsis neonatal
B) encefalopatia hipoxico isquemica
C) Meningitis neonatal
D) Hipoglicemia neonatal
E) Hemorragia intraventricular

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Sepsis neonatal). encefalopatia hipoxico isquemica. :::tip Cualquiera de los 3 dolores + fiebre + leucorrea = PIP. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 137 · 2.01.2.015 · Meningitis bacteriana

Lactante de 3 meses con fiebre 39°C, rigidez de nuca, fontanela abombada y letargia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar, punción lumbar y ATB empírico EV inmediato (ampicilina + cefotaxima)
B) ATB oral y control en 24h
C) Solo antipiréticos y observar
D) Solicitar TAC antes de la punción lumbar
E) Alta con instrucciones

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Meningitis bacteriana en lactante <3 meses: hospitalización urgente + punción lumbar + ATB empírico inmediato (ampicilina para cubrir Listeria + cefotaxima para S. agalactiae, E. coli, S. pneumoniae).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 80 · 2.01.2.015 · Meningitis bacteriana

Escolar de 10 años con fiebre alta, rigidez de nuca, fotofobia y petequias en piel. Sospecha de meningitis bacteriana. ¿Cuál es el esquema antibiótico empírico de elección?

A) Ceftriaxona + vancomicina EV
B) Ciprofloxacino EV
C) Doxiciclina oral
D) Azitromicina oral
E) Amoxicilina oral

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Meningitis bacteriana en escolar (>3 meses): patógenos principales = S. pneumoniae y N. meningitidis. ATB empírico: ceftriaxona 100 mg/kg/día (cobre ambos) + vancomicina (por neumococo resistente a penicilina). Se agrega dexametasona antes o junto al ATB para reducir secuelas.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 102 · 2.01.2.005 · Crisis bronquial obstructi

Niño de 7 años con asma en crisis, frecuencia respiratoria 40/min, $SatO_2$ 91%, sibilancias bilaterales, sin uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

A) Salbutamol inhalado + ipratropio + corticoides sistémicos + oxígeno
B) Adrenalina subcutánea
C) Intubación orotraqueal inmediata
D) Antibióticos EV
E) Solo oxígeno y observar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Crisis asmática moderada: broncodilatadores β2 (salbutamol) + anticolinérgico (ipratropio) + corticoides sistémicos (prednisona oral o hidrocortisona EV) + oxígeno para $SatO_2$ >94%.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 125 · 2.01.2.013 · Insuficiencia respiratoria

Niño de 3 años hospitalizado por neumonía. $SatO_2$ 88% con oxígeno por naricera a 3 L/min. FR 50/min, uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo ventilatorio?

A) Ventilación no invasiva (VNI/CPAP) o cambio a mascarilla de alto flujo
B) Intubación orotraqueal inmediata
C) Aumentar flujo de oxígeno por naricera a 6 L/min
D) Adrenalina nebulizada
E) Alta con oxígeno domiciliario

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Niño con neumonía grave que no responde a oxigenoterapia convencional + signos de trabajo respiratorio aumentado: siguiente escalón = VNI (CPAP o BPAP) antes de intubación, según protocolo actual.

OBSTETRICIA & MATERNO-FETAL

Módulo 3: Materno - Infantil · Colección Tomo 19

167 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

26 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.1.001	Aborto espontáneo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	13 Q	Tomo 19 · 19.10 (Pág. 35)
3.01.1.002	Anemia y embarazo	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 19 · 19.11 (Pág. 39)
3.01.1.003	Colestasia gravídica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 19 · 19.8 (Pág. 28)
3.01.1.004	Diabetes y embarazo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 19 · 19.7 (Pág. 24)
3.01.1.005	Embarazo con edad gestacional dudosa	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · 19.14 (Pág. 52)
3.01.1.006	Embarazo ectópico no complicado	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	13 Q	Tomo 19 · 19.15 (Pág. 56)
3.01.1.007	Embarazo múltiple	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · 19.16 (Pág. 60)
3.01.1.008	Enfermedad del trofoblasto	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 19 · 19.17 (Pág. 62)
3.01.1.009	Macrosomía fetal	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 19 · 19.18 (Pág. 66)
3.01.1.010	Restricción de crecimiento fetal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	10 Q	Tomo 19 · 19.4 (Pág. 11)
3.01.1.011	Síndrome hipertensivo del embarazo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 19 · 19.5 (Pág. 18)
3.01.1.031	VIH en ginecobstetricia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.003	Crisis hipertensiva del embarazo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.004	Eclampsia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · 19.6 (Pág. 20)
3.01.2.005	Embarazo ectópico complicado	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.006	Endometritis puerperal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.007	Hiperemesis gravídica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.009	Mastitis puerperal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.010	Metrorragia: Desprendimiento previo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.011	Metrorragia: placenta previa	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.2.012	Parto prematuro	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	18 Q	Tomo 19 · C.38 (Pág. 80)
3.01.2.013	Presentaciones fetales anómalas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.014	Rotura prematura de membranas	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	12 Q	Tomo 20 · C.40 (Pág. 84)
3.01.2.015	Rotura uterina	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.017	Sufrimiento fetal agudo	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.021	Trabajo parto distócico	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	5 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 49 3.01.2.010 · Metrorragia: Desprendimien

Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas y metrorragia. Al examen se palpa un útero con tono aumentado y tres contracciones uterinas en 10 minutos. La especuloscopía muestra sangre roja oscura en can8dad moderada, sin dilatación cervical. Los la8dos cardiofetales se auscultan a 130 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Realizar maduración pulmonar y conducta expectante
C) Inducir el trabajo de parto con misoprostol
D) Solicitar Doppler fetal
E) Administrar tocolí2cos endovenosos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), que se debe interrumpir de inmediato por la vía más expedita, la que, por no tener dilatación cervical, es la cesárea de urgencia. La única excepción, que se puede hospitalizar y observar con mucho cuidado, es que sea menor a 34 semanas, con sangrado escaso, madre bien, feto bien y sin dolor ni contracciones (en otras palabras, < 34 semanas con un poquito y todo tranquilizador).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 7 3.01.2.010 · Metrorragia: Desprendimien

Una paciente de 30 años, con embarazo de 35 semanas controlado, consulta al servicio de urgencias por metrorragia escasa asociada a dolor abdominal. Al examen físico destaca aumento marcado del tono uterino de forma permanente y frecuencia cardiaca fetal de 110 por minuto. El diagnóstico más probable es:

A) Placenta previa
B) Rotura uterina
C) Rotura de vasa previa
D) Síntomas de parto prematuro
E) Desprendimiento de placenta

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Desprendimiento de placenta** (opción **E**). Metrorragia más dolor e hipertonía uterina. Además FCF en límite bajo.. Metrorragia del tercer trimestre acompañada de dolor abdominal súbito y marcada hipertonía uterina ("útero leñoso o en tabla") con sufrimiento fetal agudo es la tríada clásica de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), una urgencia obstétrica que exige interrupción inmediata (cesárea).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 166 3.01.2.010 · Metrorragia: Desprendimien

paciente de 28 años de edad, con 34 semanas de gestación consulta por metrorragia moderada. Al examen físico tiene presión arterial: 130/70 mmHG y FC: 107x', útero doloroso e hipertónico y metrorragia escasa en la especuloscopía. Se realiza ecografía obstétrica que resulta normal, con placenta posterior, sin signos de desprendimiento. El doppler maternofetal resulta normal normal y el cuello tiene 30 mm de longitud. La conducta mas adecuada con la paciente es:

A) Administrar nifedipino
B) Inducción de parto
C) Repetir el doppler fetal en 7 días
D) Realizar rotura de membranas
E) Realizar cesárea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque la ecografía no lo vea, el diagnóstico clínico es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que requiere de interrupción por la vía más expedita: en este caso cesárea, por no estar en trabajo de parto avanzado.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 96 3.01.2.010 · Metrorragia: Desprendimien

DPPNI (útero tónico, sangrado escaso) 32 sem aprox, se evidencia en eco leve desprendimiento de placenta. Cuál es la conducta:

A) Cesarea
B) Interrumpir 34 sem
C) Dar corticoides e interrumpir en 48 hrs, era un DPPNI leve, sin sufrimiento fetal, no creo que sea cesárea de urg más considerando que tiene <34
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Cesarea** (opción **A**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 150 3.01.2.010 · Metrorragia: Desprendimien

Una paciente de 32 años, con 32 semanas de embarazo, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas, asociada a metrorragia. Al examen físico se palpa aumento del tono uterino, se objetiva metrorragia escasa y contracciones uterinas hipertónicas a razón de 3/10 minutos. El cuello uterino no tiene modificaciones y los latidos cardiofetales se auscultan a 120 lpm. La conducta más adecuada es:

A) Interrumpir el embarazo de inmediato
B) Administrar corticoides intramusculares
C) Solicitar perfil biofísico
D) Solicitar Doppler materno-fetal
E) Administrar tocolíticos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un DPPNI sintomático, por lo que se debe interrumpir por la vía más expedita, a pesar de que los LCF estén normales.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 36 3.01.2.010 · Metrorragia: Desprendimien

Una mujer de 33 años, cursando con un embarazo de 26 semanas, sufre un accidente de tránsito, por lo que es llevada al servicio de urgencias, constatándose metrorragia moderada. Desde el punto de vista obstétrico, lo primero que se debe evaluar es:

A) La vitalidad fetal
B) La ubicación placentaria
C) La dilatación cervical
D) La dinámica uterina
E) La integridad de las membranas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El bienestar fetal siempre es lo primero a evaluar en un traumatismo obstétrico o en cualquier patología aguda del embarazo, ya que podría determinar una cesárea de urgencia.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 24 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente de 34 años, tiene un embarazo de 35 semanas, con feto creciendo en el percentil 2, desde la semana 33, con Doppler fetal normal, en ese entonces. Se solicita un nuevo Doppler fetal de control, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Inducir el parto
B) Realizar cesárea
C) Solicitar perfil biofísico
D) Controlar semanalmente con el Doppler
E) Interrumpir a las 37 semanas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un RCIU severo (p2 o menos), por lo que se interrumpe a las 34 semanas, por cesárea. RCIU no severo (p3-4: moderado; p5-9: leve) y con Doppler normal: 37 semanas por parto vaginal. Doppler alterado siempre cesárea a las 34 semanas (flujo umbilical ausente en diástole), 30 semanas (flujo reverso en diástole) o 26 semanas (ducto venoso reverso).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 161 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una altura uterina de 28 cm. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto creciendo en percentil 8, con ILA de 8 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto con misoprostol
B) Realizar registro basal no estresante
C) Observar evolución
D) Realizar doppler materno fetal
E) Realizar operación cesárea

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy específica. Tiene un RCIU leve (percentil mayor a 5), con líquido amniótico límite, aunque al término, se considera normal hasta ILA de 5. Hoy en día, se pide Doppler umbilical, porque si está normal, se puede incluso llegar a término. Antes se interrumpían todos los RCIU a más tardar a las 37 semanas (hoy solo los moderados-severos o los con doppler alterado).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 168 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente cursando un embarazo de 35 semanas, es diagnosticada de RCIU en percentil 3. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es una indicación de interrupción inmediata del embarazo?

A) Oligohidroamnios
B) Aumento de la resistencia de las arterias umbilicales
C) Dilatación de la arteria cerebral media
D) Relación femoro/abdominal mayor a 0,25
E) Ducto venoso con flujo ausente en diástole, al doppler

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El doppler ducto venoso alterado es ominoso (también el OHA severo y el doppler umbilical con flujo ausente o reverso en diástole).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 56 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente multípara, de 40 años, cursando un embarazo de 32 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra líquido amniótico sin alteraciones, con un feto creciendo en percentil 10 para la edad gestacional, con un peso fetal estimado de 1.320 gramos. ¿Cuál es la actitud más adecuada?

A) Observar evolución
B) Solicitar ecodoppler uterina
C) Solicitar ecodoppler umbilical
D) Repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas
E) Inducir maduración pulmonar con corticoides

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El retraso del crecimiento intrauterino se estudia con Doppler umbilical, como examen de elección (permite diferenciar el PEG del RCIU y además determina la gravedad del RCIU, de manera de determinar la edad de interrupción). Varias de las otras opciones (D y E) serán correctas, dependiendo del resultado del doppler.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 149 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 36 semanas, con feto creciendo en percentil 6 en la semana 35, con Doppler materno fetal normal en ese entonces. Se realiza ecografía de control que muestra feto que no ha crecido, en presentación podálica y Doppler normal. El registro basal no estresante es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar perfil biofísico
B) Administrar corticoides
C) Interrumpir a las 37 semanas
D) Realizar cesárea en este momento
E) Continuar el control semanal con Doppler

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta difícil. Tiene un RCIU leve (p5 a p9) con Doppler normal, por lo que sería un RCIU tipo I, que se interrumpe a las 37 semanas o incluso a las 40 semanas, si es que se considera un PEG (todo bien y Doppler normal, como en este caso). Para hablar de detención del crecimiento deben pasar al menos 2 semanas, ya que en un tiempo menor está dentro de la variabilidad de la misma ecografía. Por tanto, en este caso, se debe seguir controlando con el Doppler semanal. Si tuviera menos de 34 semanas sí se darían corticoides. El PBF probablemente también se pediría.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 123 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una estimación de peso fetal en el percentil 5 para la edad gestacional. Se realiza una ecografía obstétrica, que confirma feto con peso en percentil 5 para la edad e índice de líquido amniótico de 6. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar registro basal no estresante
B) Inducir el parto
C) Solicitar Doppler maternofetal
D) Realizar amnioinfusión
E) Realizar cesárea

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un RCIU leve (p5 a p9), con un ILA normal para la edad gestacional (OHA se define como ILA menor a 8 o menor a 5 si es de término; por tanto, no hay OHA en este caso). Sea como sea, todo RCIU siempre debe estudiarse con un doppler maternofetal, ya que si todo está bien, puede ser PEG y se puede esperar a las 40 semanas y nacer por vía vaginal; si está alterado el doppler, se debe interrumpir por cesárea (por tener ya 37 semanas). Revisar manejo y edades de interrupción del RCIU

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 156 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 38 semanas, con antecedente de RCIU en percentil 5. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil menor a 5 y oligohidroamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar corticoides, manteniendo una conducta expectante
B) Realizar cesárea dentro de las próximas 24 horas
C) Inducir el parto con misoprostol
D) Solicitar doppler umbilical y decidir según resultados
E) Realizar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un RCIU, con criterios de interrupción (mayor a 37 semanas y además OHA y además detención del crecimiento). Se prefiere la cesárea para evitar el estrés del trabajo de parto.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 29 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Embarazada de 35 semanas, con altura uterina menor a lo esperado, es derivada a alto riesgo obstétrico donde se realiza ecografía que muestra feto de 1.800 gramos y el doppler umbilical muestra flujo reverso en diástole. La paciente está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y su tacto vaginal no presenta cambios cervicales. La conducta más adecuada es:

A) Inducir con misoprostol y conducir trabajo de parto
B) Interrumpir por cesárea
C) Hospitalizar para estudio de la unidad fetoplacentaria
D) Solicitar estudio de líquido amniótico
E) Indicar reposo y control en 48 horas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un RCIU mayor a 34 semanas y cuyo Doppler umbilical está alterado, por lo que se debe interrumpir. Por tener el doppler alterado, es decir, insuficiencia placentaria no se lo debe someter al estrés del parto vaginal.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 164 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente de 25 años, cursando embarazo de 35 semanas, acude a control ginecológico asintomática. Su examen físico es normal. Se realiza ecografía donde se estima peso fetal en percentil 8 para su edad gestacional. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar perfil biofísico
B) Medición del flujo cerebral y umbilical
C) Medición del flujo de arterias uterinas
D) Realizar ecografías seriadas
E) Interrupción del embarazo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un RCIU leve, de 35 semanas. Hay que pedir Doppler umbilical y se puede ver además con el de ACM. Pero también se debe pedir un PBF y la eco en 14 días. A grandes rasgos, el Doppler es el examen más importante en el RCIU. Esta pregunta está técnicamente mala, pero para asunto de examen RCIU = doppler umbilical (que se puede complementar con doppler de ACM y de ducto venoso).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 141 3.01.1.010 · Restricción de crecimiento

Una paciente de 29 años, primigesta, cursando un embarazo de 26 semanas, con feto creciendo bajo el percentil 10 para la edad gestacional, se realiza una ecografía-doppler para evaluar el bienestar fetal. ¿Qué alteración obligaría a interrumpir el embarazo de inmediato?

A) Aumento del índice cerebroplacentario
B) Aumento de resistencia de las arterias uterinas
C) Ducto venoso reverso en diástole
D) Flujo umbilical ausente en diástole
E) Alteración del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Ducto venoso reverso en diástole). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Aumento del índice cerebroplacentario, Aumento de resistencia de las arterias uterin) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 22 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una mujer de 38 de años, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto. Actualmente tiene 7 cm de dilatación y se palpa la cabeza fetal ascendida, 2 centímetros por sobre las espinas isquiáticas. Presenta dinámica uterina de 4 a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos, recibiendo goteo oxitócico. Luego de 2 horas de observación no se presentan cambios en las condiciones obstétricas y, poco después, aparecen múltiples desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal y el líquido amniótico se tiñe de meconio. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender oxitocina, lateralizar y controlar por 30 minutos
B) Realizar operación cesárea de inmediato
C) Administrar anestesia epidural y conducir el trabajo de parto
D) Aumentar la dosis de oxitocina y, una vez que se logre el descenso de la cabeza, realizar fórceps
E) Solicitar ecografía Doppler fetal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Sufrimiento fetal y prueba de parto fracasada: La paciente presenta signos de sufrimiento fetal, incluyendo desaceleraciones tardías en el registro fetal y líquido amniótico meconial. Si bien sería aceptable comenzar con la reanimación intrauterina, en este caso, además, se observa una prueba de parto fracasada, por lo que se debe indica cesárea de inmediato.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 88 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Paciente de 30 años, multípara de 1 parto vaginal, presenta parto de término, con 4 cm de dilatación, membranas rotas, se administra anestesia peridural, presentando PA 100/65 mmHg, LCF 90/min y 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

A) Administrar volumen y monitorizacion fetal
B) Realizar cesárea de urgencia
C) Iniciar tocolisis de urgencia
D) Realizar fórceps
E) Iniciar amniotransfusión

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pareciera un desprendimiento de placenta, pero le falta la metrorragia. De todos modos, está con un sufrimiento fetal agudo (FC: menor a 100) y la bradicardia fetal es indicación de interrumpir por la vía más expedita y en este caso es la cesárea, porque está en fase activa y no se puede hacer un fórceps (a menos que esté en expulsivo: 10 cm, con descenso en tercer plano de Hodge o espinas +2).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 170 · 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente presenta embarazo de término. Inicia trabajo de parto con 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y dilatación cervical de 6 cm. El registro fetal muestra variabilidad disminuida de la frecuencia cardiaca fetal. A las 2 horas mantiene dinámica uterina, tiene dilatación de 8 cm y el registro muestra variabilidad disminuida, pero además, presencia de desaceleraciones tardías, en relación a cada contracción uterina. La conducta más adecuada es:

A) Realizar fórceps
B) Realizar operación cesárea
C) Administrar misoprostol
D) Iniciar oxitocina en goteo
E) Mantener una conducta expectante y reevaluar en 30 minutos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un MEFI III (variabilidad disminuida + desaceleraciones tardías), por lo que tiene un sufrimiento fetal, que debe ser interrumpido por la vía más expedita. No se puede hacer fórceps, porque tiene solo 8 cm de dilatación. Así que se debe hacer cesárea de urgencia.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 118 · 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente de 33 años, cursando embarazo de 40 semanas, inicia trabajo de parto. Se realiza control del parto, que constata dilatación cervical completa y cabeza en espinas +2. El monitoreo electrónico fetal muestra lo siguiente: La conducta más adecuada es:

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Realizar fórceps
C) Solicitar perfil biofísico
D) Lateralizar a la madre y administrarle oxígeno
E) Mantener una conducta expectante

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una bradicardia fetal mantenida (mayor a 10 minutos), por lo que se debe interrumpir inmediatamente por la vía más expedita. En este caso, la vía más expedita es el fórceps, ya que cumple con todos los requisitos: cefálica, dilatación completa, espinas +2 y anestesia (aunque no se menciona, pero tampoco se puede hacer una cesárea sin anestesia).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 71 · 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 39 semanas inicia trabajo de parto. Al tacto vaginal, tiene feto en cefálica, con cuello borrado, con 8 cm de dilatación y membranas íntegras. Se realiza un registro fetal intraparto, cuyo trazado se muestra a continuación: INSERTAR FOTO ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener una conducta expectante
B) Realizar rotura de membranas
C) Realizar cesárea de urgencia
D) Iniciar oxitocina endovenosa
E) Solicitar perfil biofísico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Era un registro ominoso, con múltiples desaceleraciones variables complejas. Fal- taba un buen trazado de la dinámica uterina, ya que en ese parecía no haber contracciones.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 148 · 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente de 27 años, multípara, cursando un embarazo de 38 semanas, en trabajo de parto en fase activa, se produce rotura de membranas, con salida de líquido amniótico claro, luego de lo cual la frecuencia cardíaca fetal disminuye a 90 latidos por minuto. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizarse en esta paciente?

A) Realizar perfil biofísico
B) Realizar cesárea
C) Cambiar de posición a la madre
D) Realizar tacto vaginal
E) Realizar Doppler fetal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una procidencia de cordón, por lo que se debe interrumpir de inmediato. El TV ayuda a 1. descomprimir el cordón umbilical y 2. determinar las condiciones obstétricas para la vía más expedita de parto (aunque suele ser por cesárea en la procidencia de cordón). La bradicardia también obliga a interrumpir por la vía más expedita (por tanto, hay que hacer también un TV).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 169 · 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente de 37 años, está en trabajo de parto de término. Está con anestesia raquídea y oxitocina en goteo. Presenta registro electrónico fetal tipo III y se constatan 6 contracciones uterinas cada 10 minutos. La conducta más adecuada es:

A) Poner a la madre en decúbito lateral izquierdo
B) Suspender la oxitocina
C) Realizar rotura artificial de membrana
D) Dar oxígeno a la madre
E) Administrar tocolíticos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un registro ominoso, con taquisistolía, así que lo primero a hacer es suspender la oxitocina. Sin embargo, también hay que lateralizar, dar O2, etc, por lo que es una mala pregunta.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 22 · 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 36+2 semanas, acude al servicio de urgencia por contracciones uterinas dolorosas y frecuentes. Al examen físico tiene altura uterina: 32 cm, estimación de peso fetal en percentil 25 y se constatan 5 contracciones uterinas cada 10 minutos. El tacto vaginal demuestra dilatación cervical de 4 cm y membranas íntegras. Se auscultan los latidos cardiofetales a 140x' y se realiza registro fetal, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Realizar rotura de membranas
C) Inducir con misoprostol
D) Inducir con goteo oxitócico
E) Controlar en dos horas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar cesárea de urgencia** (opción **A**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 97 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente de 22 años, cursando un embarazo de 37 semanas, en trabajo de parto, presenta dilatación cervical de 5 cm, con buena dinámica uterina y presentación cefálica. Se produce rotura espontánea de las membranas, saliendo líquido amniótico hemático y apareciendo una bradicardia fetal mantenida. La conducta más adecuada es:

A) Dejar a evolución espontánea
B) Realizar un tacto vaginal
C) Administrar tocolíticos de urgencia
D) Lateralizar y dar oxígeno a la madre
E) Solicitar Doppler fetal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil, por la redacción, que no permite diferenciar entre una procidencia de cordón y una rotura de vasa previa (ambas tienen sufrimiento fetal, tras la rotura de membranas, pero la rotura de vasa previa tiene metrorragia y, en este caso, solo se dice líquido hemático, lo que orienta más a rotura de vasa previa). De todos modos, el tratamiento en ambas es la interrupción inmediata, por la vía más expedita y aquella se determina con el tacto vaginal (sin embargo, en este caso, se indica que ya tenía 5 cm, por lo que la vía más expedita es la cesárea). En el caso de la procidencia de cordón, el TV, además, podría ayudar a descomprimir el cordón, mientras se organiza el equipo para la cesárea de urgencia (esto hace pensar que realmente se quería preguntar una procidencia de cordón, ya que es la única opción aceptable).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 160 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Una paciente de 30 años de edad, cursando un embarazo de 40 semanas, inicia tra- bajo de parto en cefálica. Al tacto vaginal tiene 7 cm de dilatación, con membranas ínte- gras, por lo que se realiza rotura artificial de membranas, que da salida a líquido claro. A los pocos minutos evoluciona con registro fetal tipo III, por bradicardia fetal. La pri- mera conducta a realizar es:

A) Realizar tacto vaginal
B) Cambiar de posición a la madre
C) Administra nifedipino
D) Dar oxígeno a la madre
E) Realizar cesárea de urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una procidencia de cordón. Se diagnostica con el TV y permite empujar la ca- beza fetal, para evitar la muerte del feto, hasta que se haga la cesárea.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 54 3.01.2.017 · Sufrimiento fetal agudo

Embarazada de 33 semanas, hospitalizada por preeclamsia, comienza con dinámica uterina de 3 en 10 minutos, sus últimos examenes de control presenta creatinina 1,5mg/dL y proteinuria de 24 horas 2 gramos. Al examen físico presenta presión arterial de 150/90, reflejos osteotendíneos presentes, tacto vaginal sin cambios cervicales. Se realiza monitoreo fetal que muestra variabilidad de 3 latidos por minutos y desaceleraciones tardias. La conducta más adecuada es:

A) Administrar tocolíticos e interrumpir a las 34 semanas
B) Administrar labetalol endovenoso y mantener conducta expectante
C) Realizar perfil biofísico
D) Solicitar ecografía doppler umbilical
E) Interrupción del embarazo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El registro está ominoso (variabilidad disminuida y desaceleraciones tardías). Es un MEFI 3 y por tanto se debe interrumpir. Lo difícil es que para interrumpirlo debe estar 20 minutos al menos en MEFI 3 o 2 minutos en bradicardia sostenida. Sin embargo, cuando se pregunte un registro malo, la respuesta a marcar es la interrupción por la vía más expedita, ya que se asume que el registro lleva al menos 20 minutos. La excepción es si se dijera que lleva pocos minutos con ese registro.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 60 3.01.1.004 · Diabetes y embarazo

Una mujer de 35 años, con embarazo de 15 semanas, sin síntomas, en exámenes de control destaca VDRL negativo, hemoglobina de 11,5 mg/dL y glicemia de ayuno 108mg/dL. Su examen físico es normal, con altura uterina sobre el pubis. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Solicitar test de tolerancia oral a la glucosa
B) Indicar dieta y mantener control habitual
C) Solicitar hemoglobina glicosilada
D) Indicar insulina subcutánea
E) Solicitar nueva glicemia de ayunas

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una glicemia mayor a 105 (ahora el corte es 100). Si fuera menor a 100 se observa, si es mayor, se repite. El TTGO se pide a las 28 semanas y luego a las 32 si hay macrosomía, PHA o antecedentes de DMG en otro embarazo.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 38 3.01.1.004 · Diabetes y embarazo

Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 28 semanas, sin alteraciones hasta el momento, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, con 75 gramos de glucosa, que resulta 75 mg/dl basal y 160 mg/dl a las 2 horas de la carga de glucosa. El diagnóstico más probable es:

A) Intolerancia a la glucosa
B) Diabetes gestacional
C) Diabetes pregestacional
D) Djabetes mellitus 2
E) Resistencia a la insulina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es diabetes gestacional (DMG) por diagnosticarse durante el embarazo y por cumplir con el criterio de TTGO mayor o igual a 140 (es el corte en la DMG). No es pregestacional (DMPG), ya que esta se diagnostica antes del embarazo, o al inicio del embarazo, pero con 2 glicemias de ayuno mayores o iguales a 126 mg/dl o con una glicemia mayor o igual a 200 mg/dl más síntomas). Si se diagnostica en el segundo semestre, solo se puede hablar de DMG y no DMPG.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 9 3.01.1.004 · Diabetes y embarazo

Una paciente embarazada de 32 semanas, con altura uterina: 38 cm e IMC: 33 se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil 93, con ILA: 12. Se solicita test de tolerancia a la glucosa oral, que resulta 92 mg/dl basal y 170 mg/dl a las dos horas postcarga de glucosa. ¿Cuál es la causa más probable de la condición fetal?

A) Diabetes mellitus gestacional
B) Obesidad materna
C) Diabetes mellitus pregestacional
D) Incompatibilidad de grupo Rh
E) Síndrome hipertensivo del embarazo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diabetes gestacional: El feto presenta un tamaño grande para la edad gestacional, definido como un percentil mayor a 90 en el peso/edad. El líquido amniótico es normal (polihidramnios: ILA > 20; oligohidramnios: ILA < 8). El test de tolerancia a la glucosa oral diagnostica diabetes gestacional. El test normal es menor a 100 en ayunas (normal en este caso) y menor a 140 después de la carga (170 en este caso). En una mujer no embarazada, el diagnóstico sería intolerancia a la glucosa oral (glicemia poscarga 140-199); en cambio la diabetes en no embarazadas se diagnostica con glicemia poscarga mayor o igual a 200.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 73 3.01.1.004 · Diabetes y embarazo

Una paciente de 37 años, cursando embarazo de 29 semanas, se realiza un test de tolerancia a la glucosa oral, de 75 gramos, que muestra glicemia basal de 86 mg/dl y postcarga de 139 mg/dl. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar dieta hipoglucídica y controlar con glicemias seriadas
B) Solicitar hemoglobina glicosilada
C) Iniciar metformina
D) Repetir el examen a las 32 semanas
E) Mantener el control habitual del embarazo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener el control habitual del embarazo** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 23 3.01.1.004 · Diabetes y embarazo

Embarazada de 8 semanas consulta por exámenes. Se realiza PTGO 75g: glicemia ayuno 88 mg/dL y a las 2 horas 140 mg/dL. ¿Cómo se interpreta este resultado?

A) Resistencia a la insulina
B) Normal para el embarazo
C) Diabetes pregestacional
D) Diabetes gestacional
E) Intolerancia a la glucosa gestacional

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

PTGO en embarazo (ADA/OMS): diagnóstico de DG requiere glicemia ayuno ≥92, 1h ≥180 o 2h ≥153 mg/dL. Con 2h en 140 mg/dL (< 153), el resultado es NORMAL. Se realiza nueva PTGO a las 24-28 semanas si el riesgo persiste.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 82 3.01.1.008 · Enfermedad del trofoblasto

Una paciente de 25 años acude al servicio de urgencia por metrorragia abundante de 2 días de evolución. Tiene antecedente de atraso menstrual de 4 semanas, dudoso debido a reglas irregulares que ocurren cada 30 a 45 días. Al examen Fsico se realiza especuloscopía con visualización de sangre que sale del orificio cervical externo, y la palpación uterina muestra un útero aumentado de tamaño como para un embarazo de 12 semanas. Se solicita subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana, que resulta 200.000 U/L, y se realiza ecograFa transvaginal que muestra imagen en “tormenta de nieve”. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Aborto en evolución
B) Embarazo roto
C) Mola hida2diforme
D) Metrorragia disfuncional
E) Tumor del si2o de inserción placentaria

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un embarazo molar, confirmado con la ecografía. La HCG muy elevada también la sugiere, al igual que el útero de tamaño mucho mayor al esperado para su edad gestacional (suprapúbico equivale a 12 semanas).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 174 3.01.1.008 · Enfermedad del trofoblasto

Una mujer de 30 años, cursando un embarazo inicial, presenta un aborto espontáneo, que es manejado con legrado, con buen resultado y sin complicaciones. Se controla dos semanas después y la biopsia es informada como “mola hidatiforme”. La conducta más adecuada es:

A) Indicar anticonceptivos orales por 12 meses
B) Controlar con beta-HCG seriada
C) Controlar con ecografía transvaginal en 2 semanas
D) Quimioterapia profiláctica
E) Realizar histerectomía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Lo más importante es la HCG seriada, para detectar precozmente la aparición de una neoplasia trofoblástica gestacional. Sin embargo, también deberá quedar con ACO, para evitar un embarazo que eleva la HCG y alterará el seguimiento.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 155 3.01.1.008 · Enfermedad del trofoblasto

Una paciente se realiza un legrado por un aborto espontáneo. La biopsia es informada como “mola completa”. Su HCG postlegrado es de 750 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Seguirla con niveles seriados de HCG
B) Realizar biopsia endometrial
C) Indicar anticonceptivos con progestágeno solo
D) Repetir el legrado
E) Indicar metotrexato

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ante un embarazo molar se debe seguir con HCG, después de sacarla. Si se eleva o mantiene sin bajar, se diagnostica neoplasia trofoblástica gestacional y se procede a la histerectomía más quimioterapia con metotrexato. Una HCG de 750 postlegrado, es bastante baja.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 65 3.01.1.008 · Enfermedad del trofoblasto

Paciente de 34 años, sin antecedentes, consulta por atraso menstrual asociado a metrorragia abundante, náuseas y vómitos. Al examen físico se aprecian mucosas pálidas, útero a nivel suprapúbico y se palpan masas anexiales bilaterales no sensibles. El diagnóstico más probable es:

A) Embarazo normal
B) Aborto en evolución
C) Adenomiosis
D) Embarazo gemelar
E) Embarazo molar

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Embarazo molar** (opción **E**). Es una mola completa, con los quistes tecoluteínicos, la metrorragia y los vómitos.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 138 3.01.1.008 · Enfermedad del trofoblasto

Una paciente de 25 años presenta un aborto espontáneo, hace 2 meses, que no re- quirió de legrado. Actualmente presenta metrorragia de 7 días de evolución, que en la especuloscopía se aprecia que sale del orificio cervical externo. Su HCG resulta 135.000 UI/L. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra útero aumentado de tamaño, con contenido uterino irregular y múltiples vesículas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar metotrexato
B) Esperar evolución espontáneo
C) Realizar legrado
D) Realizar resonancia magnética nuclear de pelvis
E) Realizar histerectomía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una neoplasia trofoblástica gestacional, que se trata con histerectomía y poste- riormente sí recibirá metotrexato.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 90 3.01.1.008 · Enfermedad del trofoblasto

Mujer de 40 y tantos con aborto y a la especuloscopía se ve salida de vesículas: a. Enfermedad trofoblastica

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Todas las anteriores son correctas, No se dispone de información suficiente) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 145 3.01.1.008 · Enfermedad del trofoblasto

Una paciente de puérpera de 3 meses, cuyo parto fue por vía vaginal, sin complicaciones. Sin embargo, desde entonces presenta metrorragia intermitente, que ha aumentado. Está dando lactancia materna y no ha tenido otros síntomas. Se solicita ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 17 mm de grosor, con algunas imágenes quísticas en su interior. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Niveles de HCG
B) Resonancia magnética nuclear de pelvis
C) Biopsia de endometrio
D) TAC de pelvis
E) Histeroscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy discutible y que no tiene una respuesta clara. Tiene una insuficiencia renal, con hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica. De las complicaciones, la hiperkalemia es la más urgente de mejorar, por el riesgo de evolucionar a una pregunta muy discutible y, además, de manejo de especialista. Lo que se pregunta es una NTG, en específico un tumor del sitio de inserción placentaria (las más rara de todas y la que menos eleva la HCG, en comparación con las molas). La conducta debe incluir solicitar niveles de HCG en toda sospecha de HCG y, si está elevada, es prácticamente confirmatoria, sin embargo, el único examen que realmente confirma el diagnóstico se debe hacer con la biopsia, por lo que la C (biopsia de endometrio) es la respuesta correcta (más aún en el tumor del sitio de inserción placentario, en que la HCG es menos sensible).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 72 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas consulta en urgencias por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se constatan contracciones de 3 en 10 minutos, cuello uterino borrado 50%, dilatación 1 cm. FCF 130 lpm con buena variabilidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial?

A) Ampicilina
B) Indometacina
C) Nifedipino
D) Sulfato de magnesio
E) Atosibán

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo del Trabajo de Parto Prematuro: En amenaza de parto prematuro menor a 34 semanas se usan corticoides y tocolíticos. La indometacina se recomienda en menores de 32 semanas; el nifedipino desde las 32 semanas en adelante. El atosibán es tocolítico de segunda línea.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 73 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas consulta en el servicio de urgencias, debido a que presenta contracciones uterinas dolorosas en su domicilio. Al examen físico se constatan contracciones uterinas de 3 en 10 minutos y se palpa el cuello uterino borrado en 50%, con dilatación de 1 cm. El registro fetal muestra frecuencia cardíaca fetal basal de 130 latidos por minutos, con buena variabilidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

A) Ampicilina
B) Indometacina
C) Nifedipino
D) Sulfato de magnesio
E) Atosibán

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo del Trabajo de Parto Prematuro: En un trabajo de parto prematuro menor a 34 semanas, se usan corticoides y tocolíticos. La indometacina se recomienda en menores de 32 semanas y el nifedipino desde las 32 semanas en adelante. El atosibán es un tocolítico de segunda línea, mientras que la ampicilina sí está indicada cuando avance el trabajo de parto, ya que se usa como profilaxis para el estreptococo del grupo B.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 88 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una mujer de 35 años, multípara de uno, cursando embarazo de 28 semanas, consulta por dolor abdominal, sin otros síntomas. Al examen se aprecia presencia de contracciones uterinas de tres en diez minutos, al tacto vaginal se palpa cuello con un centímetro de dilatación, 50% borrado. Se realiza ecografía transvaginal que muestra cérvix de 18 mm. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

A) Atosiban
B) Nifedipino
C) Fenoterol
D) Progesterona
E) Sulfato de magnesio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Parto prematuro de menos de 34 semanas, con cuello corto y con algo de modificaciones. Hay que dar corticoides y tocolíticos. Atosiban, fenoterol y nifedipino son opciones. La guía minsal dice nifedipino en primer lugar. Si no frena a las 2 horas, se hace ambocentesis y si no hay bacterias, se dan tocolíticos de segunda línea: fenoterol o atosiván. Clave Eplicación

---

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 167 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 35 años, multípara de 2, tiene un embarazo de 30 semanas. Consulta porque inició contracciones uterinas dolorosas, hace pocas horas. Al examen tiene un cuello 80% borrado, con 2cm de dilatación y 3 contracciones uterinas cada 10 minutos. El registro fetal no muestra alteraciones. ¿Cuál es la medida más importante ante esta paciente?

A) Antibióticos
B) Tocólisis
C) Conducir el trabajo de parto
D) Cerclaje
E) Interrumpir el embarazo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Tocólisis). Tiene un parto prematuro menor a 34 semanas, por lo que se debe dar tocolíticos y corticoides.. 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 164 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor abdominal. Se constatan contracciones uterinas 3 a 4 en 10 minutos y se realiza un tacto vaginal que muestra dilatación de 6 cm, con borramiento completo. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más importante para mejorar el pronóstico del recién nacido?

A) Corticoides
B) Sulfato de magnesio
C) Tocolíticos
D) Antibióticos
E) Progesterona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

A?. Nuevamente una pregunta conflictiva. Como ya está en fase activa, no sirven los tocolíticos y tampoco alcanzarán a actuar los corticoides. El sulfato de magnesio, tiene un rol neuroprotector, por lo que se administran en los casos de parto prematuro inminente (yo marqué esa, aunque el año pasado marqué corticoides), sin embargo, los corticoides igualmente se dan en una única dosis en los partos prematuros inminentes, y además, en general son lo que más incide en la prevención de morbimortalidad del RN pretérmino. Los obstetras que están redactando las preguntas del Eunacom deben recordar que este examen busca medir los conocimientos de un médico general y que están haciendo preguntas de selección múltiple, por lo que no pueden hacer preguntas que induzcan a error, sino que deben ser preguntas claras, que no dejen lugar a dudas de que evalúan un conocimiento importante que debe tener un médico general.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 11 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una mujer de 30 años, multípara de 1, cursando un embarazo de 29 semanas, con- sulta por dinámica uterina persistente. Al examen físico presenta 3 contracciones uteri- nas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra feto en cefálica, con cuello delgado y dila-

A) Dar fenoterol endovenoso
B) Dar nifedipino oral
C) Dar sulfato de magnesio endovenoso
D) Realizar cesárea de urgencia
E) Administrar corticoides

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ya que está en fase activa, están contraindicados los tocolíticos. Además la indica- ción relativa (sin evidencia) de la cesárea en el parto prematuro, es cuando tiene menos de 28 semanas o 1Kg. Los corticoides poco servirán, pero siguen siendo indicados en el parto prematuro entre 24 y 34 semanas.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 170 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 31 semanas, presenta contracciones uterinas frecuentes y dolorosas. Además, su tacto vaginal demuestra 2 cm de dilatación y 50% de borramiento. ¿Qué se debe realizar antes, para decidir si se administran o no los tocolíticos?

A) Realizar ecodoppler de arterias umbilicales
B) Determinar vitalidad y bienestar fetal mediante ecografía
C) Realizar ecodoppler de arterias uterinas
D) Realizar monitoreo electrónico de la frecuencia cardiaca fetal
E) Descartar infección con amniocentesis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

, B? Por regla general, antes de dar los tocolíticos, se debe evaluar si están contraindicados (ej. Óbito fetal, alteración grave del bienestar fetal, dilatación mayor a 3 o 6 cm, etc.). Tanto el registro, como la Ecografía se suelen solicitar. Yo marqué el registro, ya que es lo que suele estar disponible y es más rápido de hacer en ese momento.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 91 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una mujer cursando un embarazo de 27 semanas, presenta dinámica uterina persis- tente y dolorosa, asociada a fiebre hasta 38 grados. Al examen físico tiene temperatura 37,8 grados Celsius, FC: 80x', PA: 120/80 mmHg y 4 contracciones uterinas cada 10 minu- tos, que persisten, a pesar de administrar nifedipino oral. Sus exámenes de sangre de- muestran PCR: 25 ng/ml (VN: menor a 10 ng/ml) y hemograma con 12.000 glóbulos blan- cos por mm3. El monitoreo fetal es tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Interrumpir el embarazo
B) Administar fenoterol
C) Administrar atosiban
D) Realizar amniocentesis
E) Iniciar antibióticos

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
No alcanzaba a cumplir criterios de coriomanionitis, pero dado que se trataba de un parto prematuro, que no respondía a tocolíticos de primera línea, era necesario rea- lizar la amniocentesis.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 164 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente, que cursa un embarazo de 30 semanas de edad gestacional, inicia contracciones uterinas de 3 en 10 minutos. Su tacto vaginal muestra un cuello con 80% de borramiento y 3 cm de dilatación. Se administra nifedipino y la primera dosis de corticoides. Se reevalúa a las 2 horas y persiste con la dinámica uterina de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, con 4 cm de dilatación, por lo que se realiza amniocentesis, que da salida a un líquido con escasa bacterias a la tinción de Gram. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dejar a evolución espontánea
B) Administrar la segunda dosis de corticoides
C) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
D) Realizar operación cesárea
E) Administrar tocolíticos de segunda línea

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Como tiene infección está contraindicada la tocolisis de segunda línea. No tiene sentido dar la segunda dosis de corticoides. Llama la atención que no aparezcan antibióticos como alternativa, ya que son la medida más importante. Está indicado interrumpir el embarazo, pero por tener 30 semanas, está contraindicado el parto vaginal (contraindicación relativa que tenga menos de 1.500 gramos), por lo que cesárea sería la respuesta más correcta. Igual es una pregunta mala. Los ginecólogos tenían un grave problema cuando hicieron esta prueba.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 159 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 32 años, con antecedente de un parto prematuro previo a las 30 semanas de gestación, cursa un nuevo embarazo de 13 semanas. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra una longitud cervical de 28mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cerclaje cervical
B) Iniciar tocolíticos a las 28 semanas
C) Indicar progesterona endovaginal y realizar cervicometrías seriadas
D) Indicar aspirina oral
E) Realizar el control habitual del embarazo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Cuello Uterino Corto: Un cuello uterino corto se define como una longitud cervical menor o igual a 25 mm. La progesterona endovaginal se recomienda en pacientes con cuello uterino corto o con antecedentes de parto prematuro (discutible). Además, el cerclaje se indica si la paciente presenta ambas condiciones.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 104 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dinámica uterina, con contracciones dolorosas 2 en 10 minutos, que no han cedido al uso de antiespasmódicos, ni al de nifedipino. Al examen físico presenta temperatura 38,0 grados Celsius, PA: 120/80 mmHg, FC: 80x'. Su tacto vaginal tiene un cuello cerrado, duro y posterior. El monitoreo fetal muestra latidos a 145x'. Se solicita un hemograma muestra glóbulos blancos: 11.000 por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dejar a evolución espontánea
B) Solicitar perfil biofísico
C) Realizar cesárea
D) Realizar amniocentesis
E) Administrar tocolíticos de segunda línea

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene dos razones para hacer la amniocentesis: 1. Un parto prematuro que no respondió a los tocolíticos de primera línea (nifedipino) y 2. Una sospecha de infección intramniótica, pero sin cumplir los criterios de corioamnionitis (dos o más de los siguientes: fiebre > 38º, taquicardia fetal, taquicardia materna, leucorrea, dolor a la palpación uterina y blancos > 15.000).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 165 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente cursa un embarazo de 32 semanas, presenta dinámica uterina 2 a 3 contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 1 cm. El registro fetal es tranquilizador. Se administran corticoides a la madre, más nifedipino 10 mg vía oral, sin embargo persiste con la dinámica uterina una hora después. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar tocolíticos de segunda línea
B) Dejar a evolución espontánea
C) Administrar sulfato de magnesio
D) Realizar cesárea
E) Realizar amniocentesis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Al fallar los tocolíticos de primera línea, lo primero es descartar una infección con la amniocentesis.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 166 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una mujer de 25 años, primigesta, cursando su embarazo de 22 semanas, se realiza una cervicometría, que muestra un cuello de 25 mm de largo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener conducta expectante
B) Indicar progesterona oral
C) Indicar progesterona vaginal
D) Realizar cerclaje
E) Administrar corticoides

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien tiene un cuello corto, el cerclaje solo se indica cuando hay antecedente de abortos tardíos o partos prematuros muy tempranos. De lo contrario, solo se da progesterona vaginal.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 155 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una primigesta de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, se realiza una ecografía transvaginal que muestra un cuello de 20 mm de longitud, sin otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar pesario
B) Iniciar progesterona endovaginal
C) Realizar cerclaje
D) Administrar corticoides sistémicos
E) Observar evolución

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El cuello corto, con cervicometría menor a 25 mm, se maneja con progesterona endovaginal, para reducir el riesgo de parto prematuro. Si ya tiene antecedentes de incompetencia cervical o partos muy prematuros, además de la progesterona, se realiza un cerclaje electivo (no es el caso, por ser primigesta).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 179 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 21 años, primigesta, cursando embarazo de 24 semanas, se realiza control ecográfico que muestra feto creciendo en percentil 50 para la edad gestacional, con pruebas de bienestar fetales normales. Cuello uterino de 20 mm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cerclaje cervical
B) Realizar test de tolerancia a las contracciones
C) Realizar amniocentesis
D) Iniciar progesterona
E) Mantener controles habituales del embarazo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar progesterona** (opción **D**). Manejo en Urgencia (APP) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Realizar cerclaje cervical, Realizar test de tolerancia a las contraccion) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 179 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una paciente de 28 años, multípara de uno, con embarazo de 22 semanas, con an- tecedente de un parto prematuro a las 26 semanas se realiza una cervicometría de con- trol, que resulta 10 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar nifedipino oral
B) Indicar progestágenos endovaginales hasta el término del embarazo
C) Realizar cerclaje cervical
D) Realizar test de la fibronectina fetal
E) Observar evolución

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una cervicometría menor a 25 mm, por lo que se debe hacer algo: Si no tu- viera antecedentes de partos prmaturos o abortos tardíos, tendía indicación de proges- tágenos endovaginales. Si por el contrario tiene esos antecedentes, como en este caso,

---

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 72 3.01.2.012 · Parto prematuro

Una mujer de 34 años, multípara de dos, cursando embarazo de veinte semanas, con antecedente de dos partos prematuros a las 20 y 24 semanas, asintomática, acude a control. Su examen físico es normal, útero a nivel umbilical. Se realiza cervicometría de control, la cual muestra cuello de 20mm. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Solicitar perfil biofísico
B) Indicar corticoides y antibióticos, manteniendo una conducta expectante
C) Realizar cerclaje
D) Administrar tocolisis y corticoides, manteniendo una conducta expectante
E) Aplicar estrógenos tópicos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene cuello corto y el antecedente de los partos muy prematuros (probablemente abortos: menor a 22 semanas o menor a 500 gramos). Si no tuviera abortos previos, sino solo el cuello corto, habría que darle progesterona endovaginal (Progendo es el nombre comercial).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 89 3.01.2.012 · Parto prematuro

Mujer embarazada EG 10 semanas, con antecedente de PP con resultado de mortinato a las o26 semanas, con cervicometría actual de 20 mm. Conducta: a. Cerclaje de inmediato (creo que es esta porque tenía PP + CU <25 mm que es indicación de cerclaje profiláctico y esto era lo más cercano en las alternativas) b. Progesterona vaginal

A) Interrupción del embarazo
B) Maduración pulmonar y observación
C) Cesárea de urgencia
D) Inducción del parto
E) Control prenatal habitual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Interrupción del embarazo** (opción **A**). Manejo en Urgencia (APP) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Maduración pulmonar y observación, Cesárea de urgencia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 85 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Embarazada de 35 semanas con rotura prematura de membranas hace 48 horas. Sin contracciones, sin fiebre, sin signos de infección. Feto en cefálica, sin signos de sufrimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar, maduración pulmonar con corticoides, antibióticos y vigilancia
B) Inducción del parto inmediata
C) Cesárea de urgencia
D) Alta con control ambulatorio
E) Amnioinfusión

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
RPM a las 35 semanas: manejo conservador con hospitalización, corticoides (betametasona) para maduración pulmonar, antibióticos profilácticos (ampicilina + eritromicina) y monitoreo fetal estrecho.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 16 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una paciente de 34 años, multípara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido amniótico hace una hora, confirmándose rotura de membranas, con la prueba de microglobulina placentaria. La ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica, y con bienestar fetal ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea
B) Administrar corticoides
C) Inducir el parto
D) Esperar 48 horas para inicio espontáneo del trabajo de parto
E) Administrar antibióticos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La RPO o RPM (rotura prematura de ovular o de membranas) mayor a 34 semanas se induce de inmediato, si no hay contraindicación del parto vaginal (en ese caso, se haría cesárea). Las menores a 34 semanas, se mantienen con una conducta expectante, bajo antibióticos y corticoides. La alfamicroglobulina placentaria es el examen con mejor rendimiento para confirmar el diagnóstico, ante la duda clínica.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 165 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una paciente de 35 años, multípara de 1, cursando un nuevo embarazo de 35 semanas, presenta rotura prematura de membranas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar operación cesárea
B) Realizar amniocentesis
C) Interrumpir el embarazo
D) Administrar tocolíticos
E) Administrar antibióticos y mantener una conducta expectante

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La RPO mayor a 34 semanas se debe interrumpir, idealmente por vía vagina, a menos que tenga contraindicación del parto vaginal, en que se realiza cesárea.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 75 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Embarazada de 35 semanas, multípara de 2, refiere pérdida de líquido claro abundante por genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopía no se observa líquido saliendo del orificio cervical externo. Se realiza registro basal no estresante que se encuentra reactivo. El examen de elección para evaluar a esta paciente es:

A) Ecografía
B) Test de nitrazina
C) Test de cristalización
D) Detección de alfa 1 microglobulina placentaria
E) Medición del pH vaginal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La PAMG1 es de elección hoy en día, aunque suele no estar disponible y se hace el test de cristalización. Si no apareciera en las alternativas, la respuesta sería el test de cristalización, pero la PAMG1 (altísima sensibilidad y especificidad) es mejor y es la respuesta correcta. Si la pregunta estuviese planteada en términos de costos, eficiencia o algo así, sí sería el test de cristalización.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 121 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una paciente de 28 años, multípara de 2, con un parto nacido por cesárea y el segundo nacido por vía vaginal. Consulta por pérdida de líquido claro por genitales. La especuloscopía no muestra alteraciones, por lo que se realiza un test de nitrazina, con pH: 5,5. La ecografía obstétrica muestra feto en cefálica, con peso acorde para la edad gestacional, con índice de líquido amniótico de 2,2 y 128 latidos cardiofetales por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto
B) Realizar amniocentesis
C) Solicitar Doppler fetal
D) Realizar operación cesárea
E) Mantener una conducta expectante

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener una conducta expectante** (opción **E**). Manejo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Inducir el parto, Realizar amniocentesis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 103 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una paciente de 34 años, multípara, embarazada de 36 semanas, presenta pérdida de líquido abundante por los genitales, hace una hora. La especuloscpía muestra cuello cerrado, con salida de líquido y la ecografía obstétrica muestra disminución del líquido amniótico, con presentación cefálica. El registro no estresante es reactivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Mantener conducta expectante
B) Administrar corticoides
C) Interrumpir el embarazo
D) Esperar 24 horas para inicio espontáneo del trabajo de parto
E) Administrar antibióticos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una RPM mayor a 34 semanas, por lo que se debe interrumpir. En este caso no tiene indicación de cesárea, sino que bastaría con inducirla con misoprostol. Si fuera menor a 34 semanas, se maneja con corticoides, antibióticos y conducta expectante.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 128 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

¿Cuál es la conducta más adecuada para una paciente de 22 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas, que sufre una rotura de membranas, sin trabajo de parto?

A) Inducir el parto
B) Administrar antibióticos terapéuticos
C) Administrar corticoides
D) Adminitrar tocolíticos
E) Administrar sulfato de magnesio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Toda RPM mayor a 34 semanas se debe interrumpir. Si no tiene contraindicación del parto vaginal, se induce; si tiene contraindicación, se hace una cesárea. En cambio, las menores a 34 semanas se maduran con corticoides, se les da antibióticos y se interrumpen al cumplir 34 semanas, desarrollar una corioamnionitis clínica o comprobarse madurez fetal en la amniocentesis (la que se hace si hay sospecha de infección, sin cumplir criterios de corioamnionitis).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 166 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una paciente de 28 años, cursa un embarazo de 32 semanas por amenorrea, sin controles obstétricos previos. Consulta por pérdida de líquido . Al examen físico presenta temperatura 38,5 grados Celsius, PA: 120/80 mmHg, FC: 100x'. Su tacto vaginal tiene un cuello cerrado, duro y posterior. Se solicita un hemograma muestra glóbulos blancos: 11.000 por mm3. La ecografía obstétricia, que muestra oligoamnios y peso fetal de 1.100 gramos, equivalente a un embarazo de 29 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto con misoprostol
B) Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante
C) Realizae cesárea
D) Realizar amniocentesis
E) Realizar amnioinfusión, con surfactante intramniótico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta difícil, con mucha información. Era una RPO de 32 semanas, con edad gestacional incierta (puede ser aún menor) y con sospecha de infección ovular. Según recuerdo, no cumplía criterios de corioamnionitis clínica, por lo que la respuesta era la amniocentesis, en mi opinión. Sin embargo no recuerdo 100% bien esta pregunta y si hubiese tenido taquicardia materna y fetal, sí estaría indicada la interrupción por cesárea (alguien me dijo que tenía más criterios, pero según recuerdo, no los tenía).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 96 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una mujer de 34 años, cursando su primer embarazo de 36 semanas, refiere salida de abundante líquido por los genitales, no asociado a otros síntomas. A la especuloscopía vaginal no se observa salida de líquido por el orificio cervical externo, al tacto vaginal se palpa cuello sin dilatación, de localización posterior y duro, sin borramiento. Se realiza ecografía abdominal que muestra oligoamnios. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Indicar antibióticos profilácticos y mantener conducta expectante
B) Inducir parto con misoprostol
C) Realizar cesárea
D) Inducir parto con oxitocina
E) Solicitar perfil biofísico para tomar conducta definitiva

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Inducir parto con misoprostol** (opción **B**). Tiene RPO mayor a 34 semanas y el cuello está malo (Bishop bajo), por lo que no sirve la oxitocina. Manejo De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 150 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una paciente de 30 años, embarazada sin controles iniciales, con edad gestacional dudosa, consulta por pérdida de líquido por los genitales. Sus signos vitales son norma- les y al examen obstétrico no presenta dinámica uterina ni modificaciones cervicales en el tacto vaginal. Su altura uterina es de 25 cm y las pruebas de bienestar fetal son normales. Se realiza ecografía obstétrica, que muestra índice de líquido amniótico de 5,2 y biometría para 30 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto con misoprostol
B) Realizar cesárea
C) Dar antibióticos y corticoides y mantener una conducta expectante
D) Determinar madurez fetal en líquido amniótico
E) Administrar nifedipino oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

C, D? Pregunta demasiado específica y difícil y con todo al límite (si quien hizo esta pregunta es la misma persona que preguntó lo de la regurgitación tricuspidea, le comu- nico que no tiene idea de qué debe o no debe saber un médico general). Es una RPO y dado que la edad gestacional es dudosa, se hizo una biometría que tiene un rango de error de 3 semanas: así tiene entre 27 y 33 semanas. Al haber un ILA de 5,2 (aunque no describen el bolsillo, como pra saber si se puede o no hacer una amniocentesis), se pue- de hacer una amniocentesis para determinar madurez fetal: si está maduro, se inter- rumpe; si no, se mantiene la conducta expectante. Yo creo que la respuesta es la D. La alternativa C también es muy aceptable.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 66 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Paciente de 35 años, multípara, con un nuevo embarazo de 32 semanas, presenta salida de líquido amniótico por genitales. El test de cristalización confirma rotura prematura ovular. Al examen físico se constata taquicardia materna y fetal, asociada a contracciones uterinas dolorosas y útero doloroso a la palpación. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto
B) Realizar cesárea
C) Administrar corticoides
D) Administrar antibióticos
E) Administrar tocolíticos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta con información insuficiente. Tiene clínica de corioamnionitis (por lo que es una corioamnionitis), por lo que lo más correcto es interrumpir el embarazo, bajo cobertura antibiótica (clinda-genta). Ninguna de las opciones entregaba el manejo completo. Lo más importante es la interrupción del embarazo, por lo que dejaremos como correcta la B. Es importante aclarar que la corioamnionitis no es indicación per sé de cesárea y puede nacer por parto vaginal, siempre y cuando ya esté en trabajo de parto avanzado, de modo que no demore mucho en salir.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 105 3.01.2.014 · Rotura prematura de membra

Una paciente de 28 años, cursa un embarazo de 32 semanas por amenorrea, sin controles obstétricos previos. Consulta por pérdida de líquido amniótico por genitales. Al examen físico presenta temperatura 38,5 grados Celsius, PA: 120/80 mmHg, FC: 110x'. La especuloscopía muestra salida de líquido por el orificio cervical, con pH: 7. Su tacto vaginal tiene un cuello cerrado, duro y posterior. El monitoreo fetal muestra frecuencia cardíaca fetal de 180 latidos por minuto. La ecografía obstétrica, que muestra oligoamnios y peso fetal de 1.100 gramos, equivalente a un embarazo de 29 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Interrumpir el embarazo
B) Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante
C) Solicitar Doppler materno-fetal
D) Realizar amniocentesis
E) Realizar amnioinfusión, con surfactante intramniótico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una coriomanionitis clínica, por lo que se debe interrumpir bajo cobertura antibiótica, independientemente de la edad gestacional. También tiene RPM, OHA y RCIU, pero gana el diagnóstico de corioamnionitis.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 40 3.01.2.011 · Metrorragia: placenta prev

Una paciente multípara, con un parto anterior por cesárea, cursando con un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al examen físico presenta una contracción uterina cada diez minutos y se realiza ecografía que visualiza una placenta posterior que sobrepasa en dos centímetros al orificio cervical. El ecodoppler materno-fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar tocolíticos
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Administrar corticoides para maduración pulmonar
D) Repetir la ecografía a las 37 semanas
E) Realizar cesárea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una placenta previa sintomática, por lo que debe interrumpirse por cesárea. Si bien está en buenas condiciones, ya tiene más de 34 semanas, por lo que se interrumpe sin mayor riesgo de complicaciones por prematurez.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 54 3.01.2.011 · Metrorragia: placenta prev

Una mujer de 27 años, cursando un embarazo de 25 semanas, acude a control de su embarazo. Se solicita una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil 50, con líquido amniótico normal y sin alteraciones morfológicas, observándose que el borde inferior de la placenta se encuentra en contacto con el orificio cervical interno. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto
B) Realizar operación cesárea
C) Controlar con ecografía en el tercer trimestre
D) Administrar tocolíticos desde las 32 semanas
E) Solicitar Doppler de arterias uterinas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Placenta previa: Se diagnostica con la ecografía, cuando la placenta cubre completamente el orificio cervical interno. El diagnóstico generalmente se realiza a las 32 semanas de gestación, ya que antes de esa edad gestacional es frecuente que la placenta se desplace hacia arriba, resolviendo la condición. Sin embargo, si la placenta previa persiste, contraindica absolutamente el parto vaginal y se interrumpe con una cesárea electiva entre las 36 y 37 semanas de gestación. Si se presenta un sangrado significativo, se debe interrumpir el embarazo de inmediato. Es importante destacar que el término "placenta previa marginal" ya no se utiliza. En cambio, se habla de "placenta de inserción baja" cuando la placenta se encuentra a menos de 2 cm del orificio cervical interno sin cubrirlo. En este caso, el parto vaginal suele ser posible, aunque si la distancia es menor a 1 cm, se debe evaluar la conveniencia de una cesárea.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 106 3.01.2.011 · Metrorragia: placenta prev

Mujer de 29 años, cursando embarazo de 33 semanas, consulta por presentar metrorragia escasa en una oportunidad no asociado a otros síntomas. Al examen físico no se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo, resto normal. Se realiza registro basal no estresante que resulta reactivo. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Rotura de vasa previa
B) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
C) Placenta previa
D) Rotura uterina
E) Sinusorragia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Para mí es una salida del tapón mucoso (metrorragia escasa y autolimitada). Como no está dentro de las opciones marcaría la Placenta Previa, por estar todo bien, sin compromiso fetal. No habla de relaciones sexuales ni describe lesiones cervicales, como para ser sinusorragia.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 29 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 24 años presenta amenorrea de 7 semanas de evolución, por lo que consulta. Su examen físico muestra FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, sin alteraciones en su examen ginecológico. Se solicitan niveles plasmáticos de HCG, que resultan 4.000 UI/L y se realiza ecografía transvaginal que muestra una masa anexial derecha de 3 cm de diámetro, sin líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir los niveles de HCG en 48 horas
B) Realizar salpingotomía por laparotomía
C) Realizar salpingectomía por vía laparoscópica
D) Indicar metotrexato por vía intramuscular
E) Controlar con una ecografía en 10 días

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Embarazo ectópico no complicado: El diagnóstico es un embarazo ectópico no complicado, basado en los niveles de hCG mayores a 3500 y la ausencia de un saco gestacional visible en la ecografía transvaginal. La paciente no tiene contraindicaciones para el metotrexato, ya que el tumor anexial es menor a 4 cm y los niveles de hCG son menores a 5000. El tratamiento de elección en este caso es el metotrexato. Si los niveles de hCG hubieran sido inferiores a 3500, la respuesta habría sido repetir los niveles de hCG en 48 horas. Si el tumor anexial hubiera sido mayor a 4 cm o la hCG mayor a 5000, la respuesta habría sido una salpingectomía por laparoscopía. Si la paciente hubiera estado en shock, la respuesta correcta habría sido la salpingectomía inmediata, ya sea por vía abierta o laparoscópica.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 55 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 27 años presenta amenorrea de 7 semanas, por lo que se realiza un test de embarazo en orina, el que resulta positivo. Acude a control, solicitándose subunidad beta-HCG, que resulta 970 U/L y ecografía transvaginal, que muestra útero con endometrio de características normales, sin presencia de saco gestacional y visualización de un tumor anexial de 2,5 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía
B) Repetir la subunidad beta en 48 horas
C) Iniciar metotrexato
D) Repetir la ecografía en 48 horas
E) Repetir la ecografía en 7 a 10 días

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Embarazo ectópico vs. Embarazo normal: Se sospecha de un embarazo ectópico cuando una prueba de embarazo es positiva pero no se visualiza el saco gestacional en la ecografía. Para confirmar el diagnóstico, se debe analizar la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana (hCG). Si la concentración es mayor a 3500 U/L, se confirma el embarazo ectópico. Si es menor a 3500 U/L, se debe repetir la prueba en 48 horas. Es importante tener en cuenta que un tumor anexial detectado en la ecografía podría ser el cuerpo lúteo, que es una estructura normal durante la primera etapa del embarazo.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 130 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 35 años con antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica previa tratada, consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de sangrado genital escaso y dolor abdominal bajo asociado a un test de embarazo en orina positivo. Refiere 6 semanas de amenorrea. Al examen físico sus signos vitales muestran FC: 82x', PA: 110/74 mmHg y se encuentra en buenas condiciones generales, sin alteraciones en el examen abdominal. Su especuloscopía muestra escaso sangrado uterino. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Solicitar ecografía y niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana
B) Control con ecografía en 7 días
C) Realizar una laparoscopía exploradora inmediata
D) Realizar legrado uterino.
E) Solicitar una resonancia magnética nuclear de pelvis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Metrorragia en el Embarazo: En una paciente con metrorragia en la primera mitad del embarazo (por las 6 semanas de amenorrea con prueba de embarazo positiva), se debe solicitar una ecografía para diferenciar entre aborto, embarazo ectópico y mola. Los niveles de gonadotropina coriónica humana ayudan a identificar embarazos ectópicos, con valores superiores a 3.500 UI/L y ecografía negativa para gestación intrauterina. La paciente presenta estabilidad hemodinámica, lo que reduce la sospecha de un embarazo ectópico roto.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 149 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 25 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico presenta abdomen doloroso a la palpación abdominal baja, mayor en la fosa iliaca izquierda, sin signos peritoneales. Además se realiza una HCG, que resulta 5.500 UI/L y se solicita una Ecografía Transvaginal, que visualiza útero sin gestación intrauterina, con endometrio de 15 mm, y un tumor anexial izquierdo de 53 mm de diámetro, de aspecto complejo, sin líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía exploradora
B) Ralizar laparotomía exploradora
C) Indicar metotrexato
D) Solicitar ecografía en 7 días
E) Solicitar niveles de HCG y ecografía en 48 horas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un embarazo ectópico no complicado (aún), con contraindicación de metotrexato (más de 4 cm y más de 5.000 de HCG), por lo que debe tratarse con laparoscopía (tiene menos riesgo de la laparotomía). La laparotomía se usa en los casos en que se rompe.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 3 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente consulta por atraso menstrual de 7 semanas y trae test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza embarazo intrauterino y que constata la presencia de un tumor anexial derecho, complejo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar niveles de HCG en sangre
B) Solicitar una nueva ecografía transvaginal en 7 días
C) Solicitar marcadores tumorales en sangre
D) Solicitar proteína plasmática asociada al embarazo
E) Solicitar niveles de progesterona y estradiol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Ante la sospecha de embarazo ectópico, se debe pedir HCG. Si es menor a 1.500 U/L, puede ser un embarazo normal, pero de menor edad gestacional y se debe esperar 48 horas y repetir la HCG. Si la HCG es mayor a 1.500 U/L, se confirma el diagnóstico (aunque en las recomendaciones norteamericanas más recientes, se sugiere esperar a que sea mayor a 3.500, o bien a que no suba al menos un 66% en 48 horas, antes de dar el metotrexato) y se procede al tratamiento con metotrexato o cirugía.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 155 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 27 años consulta por dolor abdominal bajo de 5 horas de evolución. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca de 80 la8dos por minuto, presión arterial 110/70 mmHg, examen cardiopulmonar normal y abdomen blando, sin signos peritoneales, con dolor a la palpación del hipogastrio. Se solicita subunidad beta de gonadotropina coriónica que resulta en 1.000 UI/L y se realiza ecograFa transvaginal que muestra endometrio de 17 mm, sin lesiones anexiales ni visualización de líquido libre en la pelvis. Además de hospitalizar, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar metotrexato
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Repe2r la gonadotropina coriónica en 48 horas
D) Realizar legrado uterino
E) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es un embarazo ectópico (prueba de embarazo positiva + ecografía negativa) no complicado (hemodinamia estable y ausencia de líquido libre). Por tener HCG menor a 3.500 UI/L también puede tratarse de un embarazo normal intrauterino, pero pequeño. Se debe controlar con HCG en 48 horas. Si aumenta al menos un 66% probablemente sea un embarazo normal; si eleva menos que eso, se confirma el embarazo ectópico y se puede tratar con metotrexato u observación, si la HCG se mantiene menor a 1.000. Si hubiese tenido compromiso hemodinámico o líquido libre, la sospecha habría sido un embarazo ectópico roto, por lo que se procedería a la laparoscopía o laparotomía de urgencia. En este caso, la hospitalización está indicada por el dolor, que no permite descartar que esté empezando a complicarse.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 81 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 26 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por metrorragia escasa, sin dolor. Al examen físico. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra tumor anexial de 3 cm, sin líquido libr

E) Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
A) Controlar con ecografía en 48 horas
B) Adminstrar metotrexato
C) Controlar con HCG en 48 horas
D) Realizar legrado

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Controlar con HCG en 48 horas). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Los niveles de HCG resultan 3.400 UI/L. ¿Cuál, Controlar con ecografía en 48 horas) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 124 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 23 años, nulípara, consulta por presentar metrorragia desde ayer, no asociado a otros síntomas. Se realizó prueba de embarazo en orina que resultó positiva. Al examen físico se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero sin alteraciones y una masa anexial derecha solidoquística de tres centímetros de diámetro. Además se solicitan niveles de gonadotrofina coriónica que se encuentran en 700 mUI/mL. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Indicar tratamiento con metotrexato
B) Controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en 48 horas
C) Controlar con nueva ecografía transvaginal en siete días
D) Hospitalizar y realizar salpingectomía derecha
E) Indicar reposo y controlar con niveles de gonadotrofina coriónica y ecografía transvaginal en siete días

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Como la metrorragia no es grave (si fuera grave habría que operar de inmediato por EE roto), se puede pedir la BetaHCG en 2 días, junto a la Eco, ya que está menor a 1.200. El diagnóstico probable es un embarazo de menor edad gestacional, con síntomas de aborto, vs un embarazo ectópico, con metrorragia, sin estar del todo roto. Recordar que los EE producen también metrorragia por la insuficiencia lútea que tienen, dados los bajos niveles de HCG que alcanzan.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 77 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Mujer de 24 años con amenorrea de 5 semanas y dolor hipogástrico leve. B-hCG cuantitativa: 800 mUI/mL. Ecografía transvaginal: no se visualiza saco gestacional intrauterino. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Alta con control en 1 semana
B) Repetir B-hCG en 48 horas (debe duplicar si el embarazo es viable)
C) Ecografía abdominal
D) Laparoscopia diagnóstica inmediata
E) Metotrexato intramuscular inmediato

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

B-hCG 800 sin saco visible: la "zona discriminatoria" es ~1500-2000 mUI/mL para visibilizar saco por ecografía TV. Con 800, puede ser embarazo intrauterino muy precoz. Conducta: repetir B-hCG en 48h → si duplica, probablemente viable intrauterino; si sube <50% o baja, probable ectópico.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 81 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 32 años, usuaria de DIU, con antecedente FUR dudosa hace más de un mes, consulta por dolor abdominal bajo, asociado a escaso sangrado genital. Al examinarla, se constata PA: 110/70 mmHg, FC: 100x', abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación de la zona abdominal baja. En el examen ginecológico se observan las guías del DIU y se aprecia escasa metrorragia, que proviene del orificio cervical externo. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Ecografía transvaginal
B) Gonadotropina coriónica plasmática
C) Radiografía de abdomen y pelvis
D) Laparoscopía exploradora
E) Hemograma y PCR

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Gonadotropina coriónica plasmática). Se sospecha un embarazo ectópico y es lo primero a descartarse.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 149 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente con antecedente de atraso menstrual, consulta por metrorragia. Su última regla fue hace 3 meses. A la especuloscopía se constata metrorragia. Su PA: 132/ 84 mmHg, FC: 80x', temperatura normal. Se solicitan niveles plasmáticos deHCG, que resultan 960 UI/L. Se solicita una ecografía transvaginal, que muestra útero con endometrio refringente de 17 mm, sin visualización de saco gestacional ni masas anexiales, ni tampoco líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Observa evolución y controlar en 2 semanas
B) Solicitar ecografía en 7 días
C) Solicitar nueva HCG y ecografía en 48 horas
D) Realizar laparoscopía
E) Realizar laparotomía exploradora

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un posible embarazo ectópico y dado el buen estado de la paciente, no parece estar roto, a pesar de la metrorragia escasa. Sin embargo, por tener HCG menor a 1.500, se debe observar y repetir en 48 horas, de modo de confirmar el diagnóstico.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 162 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 30 años, con antecedente de absceso tubo-ovárico drenado, consulta por metrorragia y dolor pélvico. Es usuaria de DIU y tiene atraso menstrual de 5 semanas. Al examen físico presenta dolor a la palpación del hipogastrio y del fonde del saco de Douglas. Su PA es de 100/60 mmg y su FC es de 90x'. Se realiza beta-HCG, que resulta 5.500 UI/L, hemograma con leucocitosis de 14.000 por mm3 y ecografía transvaginal, que muestra DIU in situ, endometrio engrosado y líquido libre en el fondo de saco de Douglas. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad inflamatoria pélvica
B) Aborto incompleto
C) Embarazo molar
D) Endometritis
E) Embarazo ectópico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Embarazo ectópico** (opción **E**). Tiene la eco negativa y la HCG mayor a 1.500. Además tiene factores de riesgo: PIP previo y DIU.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 167 3.01.1.006 · Embarazo ectópico no compl

Una paciente de 32 años, hace 2 meses se implantó un DIU medicado, como método anticonceptivo. Consulta por atraso menstrual. Se realiza test de embarazo, la que resulta positiva y se solicitan niveles plasmáticos de HCG que resultan 980 UI/L. No tiene síntomas. La conducta más adecuada es:

A) Retirar el DIU
B) Solicitar una ecografía obstétrica
C) Observar evolución
D) Administrar metotrexato
E) Realizar histeroscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se debe solicitar la ecografía, no solo para ver la relación entre el DIU y el saco gestacional, sino además, para asegurarse que no sea un embarazo ectópico (alto riesgo en DIU).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 115 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Embarazada de 36 semanas con presión arterial 170/110 y cefalea frontal intensa que no cede con analgesia. Sin convulsiones. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hospitalizar, labetalol EV para control de PA, sulfato de magnesio profiláctico e interrupción del embarazo
B) Nifedipino oral y control ambulatorio
C) Sulfato de magnesio solo
D) Inducción con oxitocina inmediata sin otro manejo
E) Hidralazina oral y observar

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Preeclampsia severa a ≥34 semanas: hospitalización + control de PA (labetalol o hidralazina EV) + sulfato de magnesio para prevenir eclampsia + interrupción del embarazo una vez estabilizada.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 109 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Una paciente de 31 años con 28 semanas de gestación y antecedente de asma severo, presenta un cuadro de cefalea intensa asociada a tinitus. Al examen físico se constata presión arterial de 160/110 mmHg. El registro fetal muestra una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. No tiene focalidad neurológica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada para esta paciente?

A) Administrar labetalol endovenoso
B) Administrar nifedipino oral
C) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D) Solicitar TAC de cerebro
E) Administrar misoprostol intrarrectal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Manejo de Crisis Hipertensiva en el Embarazo: La paciente presenta una crisis hipertensiva del embarazo. El tratamiento habitual en estos casos es con labetalol intravenoso. Sin embargo, en esta paciente en particular, el uso de betabloqueadores está absolutamente contraindicado debido a su historial de asma severo. La alternativa de tratamiento en este caso es el nifedipino, que generalmente se administra por vía oral.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 45 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Una paciente de 32 años, primigesta, cursando un embarazo de 33 semanas presenta presión arterial de 162/113 mmHg en el control. Se encuentra asintomática y los latidos cardiofetales se auscultan normales. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para iniciar el tratamiento?

A) Enalapril
B) Sulfato de magnesio
C) Metildopa
D) Labetalol
E) Hidralazina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una crisis hipertensiva del embarazo (mayor o igual a 110/160), por lo que se maneja con labetalol ev (si está contraindicado, se puede usar hidralazina ev). Probablemente sea una preclamsia, pero falta información y no tiene indicación de magnesio (parto, exaltación neurológica o eclamsia: convulsiones).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 54 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Embarazada sobre 20 semanas con cefalea, fotopsias y presión 160/110 mmHg. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Nifedipino 10 mg sublingual
B) Hidralazina 5 mg EV
C) Sulfato de magnesio 4 g EV
D) Labetalol 20 mg EV
E) Metildopa 500 mg oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Labetalol 20 mg EV** (opción **D**). Labetalol 20 mg EV. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 163 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Una paciente de 27 años, cursando 36 semanas de embarazo, consulta por malestar general, asociada a cefalea, tinitus y epigastralgia. Su presión arterial es 170/100 mmHg y presenta reflejos osteotendíneos exaltados. Su tacto vaginal no muestra cambios cervicales y su registro cardiaco fetal no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Administrar labetalol
B) Iniciar alfametildopa
C) Administrar sulfato de magnesio 5 gramos endovenoso y luego 2 gramos cada hora
D) Solicitar un test de tolerancia a las contracciones
E) Realizar cesárea de urgencia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

E? Es una pésima pregunta. Todo el mundo sabe que una preclamsia grave, con probable HELLP y exaltación neurológica, se debe interrumpir o si no, se muere (es lo más importante). Además todos sabemos que primero se administra el sulfato de magnesio, mientras se prepara el pabellón para la cesárea. Como se pregunta la conducta inmediata, probablemente quien redactó esta pregunta quiere que se marque el sulfato de magnesio, pero también se debe hacer la cesárea de manera inmediata, por lo que insisto, es una mala pregunta, que induce a error. Además, no es primera vez que se pregunta, por lo que es molesto volver a encontrarse con ella, ya que no es una pregunta que mida conocimiento, sino que suerte al elegir la alternativa correcta y no evalúa medicina, sino la opinión de quien la redactó, que considera que lo más urgente es el MgSO4 o bien considera que lo fundamental es la interrupción.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 140 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 36 semanas, consulta por cuadro de una hora de evolución caracterizado por epigastralgia asociada a cefalea, sin otros síntomas. En el examen físico presenta dolor a la palpación de hipocondrio derecho, asociado a exaltación de los reflejos osteotendíneos. Al tacto vaginal se palpa cuello duro y posterior. Se auscultan latidos cardiofetales con variabilidad francamente disminuida. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar cesárea de urgencia
B) Inducir con oxitocina
C) Inducir con misoprostol
D) Lateralizar a izquierda
E) Hospitalizar y esperar a las 37 semanas para realizar interrupción

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una preclamsia grave, con exaltación neurológica y un HELLP. Hay que interrumpir. Eso sí también hay que dar MgSO4. Si se preguntara lo primero que hay que hacer: sulfato de magnesio. Si se pregunta el tratamiento: interrupción inmediata.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 63 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Una paciente de 29 años, cursando un embarazo de 35 semanas y 3 días, consulta por mareos, cefalea y fotopsias de algunas horas de evolución. Al examen físico, presenta FC: 89x', PA: 164/112 mmHg, FR: 13x', examen cardiopulmonar normal y reflejos rotulianos normales. Los latidos cardiofetales se auscultan a 130 por minuto y la altura uterina es 30 cm. No presenta dinámica uterina y su tacto vaginal no muestra modificaciones. Loa ecografía obstétrica muestra ILA: 9cm, feto en cefálica con tono y movimientos normales. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Tocolíticos y dexametasona por vía endovenosa
B) Labetalol endovenoso
C) Misoprostol intravaginal
D) Sulfato de magnesio
E) Hidralacina endovenoso

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Sulfato de magnesio** (opción **D**). Es el fármaco de primera línea con grado de recomendación A según la guía ministerial chilena para la neuroprotección materna y prevención de eclampsia.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 47 · 3.01.2.003 · Crisis hipertensiva del em

Una paciente de 27 años, mul`para de uno, con antecedente de embarazo previo sin complicaciones y parto vaginal, presenta nuevo embarazo en 37 semanas de gestación. Consulta en el servicio de urgencias por epigastralgia de dos días de evolución, asociado a contracciones dolorosas y cefalea. Al examen Fsico, presenta presión arterial 160/100 mmHg, frecuencia cardíaca 100 lpm, y examen abdominal con dolor a la palpación en el epigastrio. En el examen obstétrico, se constatan cuatro contracciones en 10 minutos y dilatación cervical de 3 cm. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran hematocrito: 29%, hemoglobina: 9,6 g/dL, plaquetas 90.000/mm³, glóbulos blancos: 10.000/mm³, LDH: 670 U/L, bilirrubina total: 2,4 mg/dL, GOT: 250 U/L, GPT: 180 U/L y proteinuria cualita8va: ++. Se administra sulfato de magnesio y labetalol, logrando estabilizar a la paciente y las pruebas de bienestar fetal resultan tranquilizadoras. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Conducir el trabajo de parto
B) Realizar cesárea en este momento
C) Completar el trabajo de parto mediante cesárea en 24 horas
D) Solicitar proteinuria de 24 horas
E) Administrar cor2coides endovenosos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy difícil, especialmente por la disociación que hay entre las recomendaciones académicas y la práctica clínica habitual. Tiene un síndrome de HELLP, en contexto de una preclamsia severa. Debe interrumpirse el embarazo de inmediato, pero ya está en trabajo de parto (se está interrumpiendo solo). Por tanto, las opciones a evaluar son conducir el trabajo de parto y realizar la cesárea en este momento. En la práctica, se van a hacer una cesárea, pero la recomendación académica y técnica es privilegiar la vía vaginal si madre y feto están estables, razón por la cual la dejamos como respuesta correcta (se explica con más detalle en la siguiente pregunta). La maduración pulmonar no está indicada después de las 34 semanas, ni antes de las 24 semanas.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 135 · 3.01.2.013 · Presentaciones fetales anó

Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por con- tracciones uterinas, que se constatan como 3-4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal pre- senta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espinas 0, en variante mentoiliaca derecha posterior. EL monitoreo fetal resulta tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora
B) Hacer fórceps
C) Realizar vaccum de la cabeza fetal
D) Realizar amnioinfusión con rotación manual
E) Hacer cesárea de urgencia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una presentación de cara, que se maneja con cesárea, salvo que sea mento- anterior, que no es el caso.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 160 · 3.01.2.013 · Presentaciones fetales anó

Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 37 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas, 3 en 10 minutos. Tiene 8 cm de dilatación, con 100% de borramiento, con feto en posición podálica y registro fetal tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tocolíticos
B) Reversión interna
C) Reversión externa
D) Fórceps
E) Operación cesárea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Operación cesárea** (opción **E**). Trabajo de parto en podálica contraindica el parto vaginal. Cesárea.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 23 · 3.01.2.013 · Presentaciones fetales anó

Mujer en trabajo de parto, feto en cefálica, Bishop 8, dilatación 10 cm, encajado, presentación de cara, Mentón- posterior cual es la conducta

A) Cesárea
B) Forceps
C) Vacum
D) Continuar tdp (la presentación de cara no tiene contraindicación de cesárea, la de frente si) eso!!! (Pero ojo la variedad de posición mento púbica = mentón-anterior, es la única NO distócica según Guevara, por lo que la Mentón posterior de este caso debería ser indicación de cesárea)... Había una opción que decía reevaluar en 2 horas
E) Realizar prueba de trabajo de parto

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Cesárea** (opción **A**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 1 · 3.01.2.013 · Presentaciones fetales anó

Las preguntas incorrectas ya no descontaban, por lo que no era recomendable omitir.

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Está en presentación cefálica (fontanela se palpa en el centro de la pelvis), pero en posición transversa, la que no debe ser confundida con la situación transversa, que sí es indicación de cesárea. Aparte de eso está todo evolucionando bien, en fase activa (4 a 9 cm de dilatación).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 97 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 21 años consulta por fiebre hasta 38,9 °C asociada a dolor hipogástrico intenso y sangrado vaginal de mal olor, que inició hace 48 horas. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 120 la8dos por minuto, presión arterial 90/60 mmHg y temperatura 38,7 °C. En el examen ginecológico se observa en la especuloscopía sangre y restos ovulares de mal olor en el canal vaginal. Además, se aprecia útero muy doloroso a la palpación y dolor a la palpación hipogástrica por vía abdominal. Se solicita ecograFa transvaginal que muestra contenido uterino irregular de 18 mm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar histerectomía
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Administrar an2bió2cos endovenosos y realizar curetaje de la cavidad uterina
D) Administrar metotrexato
E) Administrar misoprostol y conducir el trabajo de aborto

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un aborto séptico e incompleto, con restos ovulares retenidos. Se maneja con antibióticos endovenosos de amplio espectro y evacuación uterina mediante curetaje o AMEU.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 20 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 6 semanas por amenorrea, consulta por metrorragia de un día de evolución, sin otros síntomas. A la especuloscopía se observa salida de sangre por el OCE, por lo que se solicita ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional colapsado a nivel del istmo. La subunidad beta HCG plasmática resulta 5.500 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Aborto retenido
B) Amenaza de aborto
C) Aborto incompleto
D) Embarazo ectópico
E) Mola hidatidiforme

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aborto Incompleto: La presencia de un saco gestacional intrauterino descarta un embarazo ectópico. Un ismo (canal que comunica el cuello con la cavidad uterina) con el saco gestacional colapsado confirma el diagnóstico de aborto, en este caso incompleto (quedan restos del saco).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 68 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Mujer de 28 años con antecedente de 3 abortos espontáneos en primer trimestre y episodio de sangrado vaginal profuso durante el embarazo actual. ¿Cuál es el estudio más adecuado para investigar la causa?

A) Panel de trombofilias (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anti-β2-glicoproteína I)
B) Cariotipo de los padres
C) Histeroscopia diagnóstica
D) Progesterona en fase lútea
E) TSH y T4 libre

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pérdida recurrente de embarazo (≥2 abortos): descartar síndrome antifosfolípido (SAF) → anticoagulante lúpico + anticardiolipina + anti-β2-GPI. Es la causa tratable más importante.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 159 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 25 años, con antecedente de atraso menstrual de 6 semanas, consulta por metrorragia. Su test de embarazo es positivo. Su especuloscopía confirma metrorragia que proviene del orificio cervical y su tacto vaginal muestra un cuello cerrado, duro y de ubicación posterior. Se solicita una ecografía obstétrica que muestra lo siguiente: FOTO (Ecografía obstétrica con un saco gestacional de 11mm). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dar misoprostol
B) Realizar legrado
C) Controlar con nueva ecografía en 7 días
D) Realizar laparoscopía
E) Dar metotrexato

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una amenaza de aborto, sin modificaciones cervicales, por lo que hay que observar. Además, la ecografía era normal, ya que el saco gestacional era menor a 18mm. Se controla con una EcoTV en 7 días, o antes, si empeoran los síntomas.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 145 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Mujer de 28 años con antecedente de 3 abortos espontáneos en el primer trimestre. Sin causa identificada aún. Desea volver a quedar embarazada. ¿Cuál es la suplementación periconcepcional más importante?

A) Calcio 1200 mg/día
B) Ácido fólico 5 mg/día (dosis alta por abortos recurrentes)
C) Progesterona vaginal
D) Hierro elemental 60 mg/día
E) Aspirina 100 mg/día

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Abortos recurrentes: el ácido fólico periconcepcional (5 mg/día en dosis alta por antecedente de pérdidas) reduce riesgo de defectos del tubo neural y se asocia a mejor resultado gestacional. Aspirina + heparina solo si se confirma síndrome antifosfolípido. El ácido fólico es la suplementación base siempre.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 168 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente, primigesta, presenta 4 semanas de atraso menstrual, por lo que se realiza test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un saco gestacional intrauterino, con un embrión de 3 mm, sin latidos. La beta-HCG resulta 6.800 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la beta-HCG en 48 horas
B) Indicar metotrexato
C) Realizar nueva ecografía en 7 días
D) Realizar legrado en 14 días
E) Realizar legrado inmediatamente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Para diagnosticar un aborto retenido, se necesita que el embrión tenga más de 5 mm. Como tiene 3, se debe controlar en 7 a 10 días, con una nueva Eco. Si continúa sin latidos, se puede legar u observar por 2 semanas, a espera de que inicie espontáneamente el trabajo de aborto (si no inicia, se legra).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 61 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 23 años, con antecedente de 2 abortos previos de primer trimestr

E) Actualmente cursa un nuevo embarazo de 8 semanas, siendo diagnosticada de aborto retenido, mediante ecografía transvaginal. ¿Cuál es el estudio inicial para esta paciente?

A) Histerosalpingografía
B) Cariograma al padre y a la madre
C) Histeroscopía
D) Estudio de trombofilia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Histeroscopía). Las lesiones de extremidades inferiores más importantes son la fractura de fémur, la fractura de pierna y la fractura de tobillo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 10 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 30 años, con antecedente de embarazo de 7 semanas de amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra útero con presencia de un huevo anembrionado de 18 mm, sin otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía
B) Solicitar nueva ecografía en 7 días
C) Solicitar niveles seriados de HCG
D) Realizar legrado
E) Solicitar curva de progesterona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un huevo anembrionado menor a 25 mm, por lo que puede ser un aborto retenido o un embarazo normal, debiendo controlarse con una ecografía en 7 a 14 días.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 77 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 30 años, con antecedente de embarazo de 7 semanas de amenorrea, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra útero con presencia de saco gestacional de 18 mm de diámetro, sin presencia de embrión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía
B) Solicitar nueva ecografía en 7 días
C) Solicitar niveles seriados de HCG
D) Realizar legrado uterino
E) Administrar progesterona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar nueva ecografía en 7 días** (opción **B**). Si la radiografía de tobillo es normal el diagnóstico es esguince; si hay fractura el tratamiento es quirúrgico. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 48 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Mujer joven con metrorragia importante, hipotensa, taquicárdica, sangrado del OCE y saco gestacional sin LCF en ecografía. ¿Cuál es la conducta?

A) Legrado uterino
B) Misoprostol vaginal y observación
C) Metotrexato IM y control
D) Laparotomía exploradora de urgencia
E) Hospitalizar y esperar expulsión espontánea

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Legrado uterino** (opción **A**). Legrado uterino. Si la radiografía de tobillo es normal el diagnóstico es esguince; si hay fractura el tratamiento es quirúrgico. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 22 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 27 años presenta amenorrea de 8 semanas, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra un embrión de 3 mm de diámetro, sin latidos cardiofetales. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar HCG seriadas
B) Observar evolución espontánea
C) Realizar evacuación uterina
D) Controlar nueva ecografía en 7 días
E) Administrar metotrexato

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Este tema es muy importante y está bien tratado en el video de resumen de GO. Tiene un embrión sin latidos (no importa entonces ni la HCG, que se mira cuando no hay saco ni embrión; ni el diámetro del saco, que se mira cuando no hay embrión, es decir, cuando hay un huevo anembrionado). Lo único que importa es la longitud del embrión: si es menor a 7 mm, se debe controlar con una ecografía en 7 a 14 días, porque puede ser un embarazo normal muy pequeño; si es de 7 mm o más, se diagnostica el aborto retenido y se puede observar o legrar. La HCG solo sirve cuando se sospecha un embarazo ectópico, por no verse nada en la ecografía (no es el caso).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 106 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente primigesta de 40 años, con amenorrea de 8 semanas, se realiza un test de embarazo en orina, que resulta positivo. Se realiza ecografía transvaginal, que visualiza saco generacional de 15 mm diámetro, con saco vitelino, pero no se observa embrión. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la ecografía en 7 días
B) Observar evolución por 30 días
C) Realizar legrado
D) Administrar misoprostol
E) Solicitar betaHCG y niveles de progesterona

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un huevo anembrionado, pero menor a 25 mm, por lo que debe seguirse con nueva ecoTV en 7 a 10 días. La HCG se pide en la sospecha de embarazo ectópico (no confundirlos, ya que el EE no tiene saco intrauterino, sino que se ve el útero vacío). Si tuviera más de 25 mm, podría observarse (por 2 a 4 semanas) o legrarse, sabiendo que es un aborto retenido.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 129 · 3.01.1.001 · Aborto espontáneo

Una paciente de 35 años consulta por metrorragia abundante de 6 horas de evolución. Al examen físico está orientada, sudorosa, tiene presión arterial: 88/58 mmHg, frecuencia cardíaca: 120x', se observa pálida y tiene frialdad de extremidades. En el examen ginecológico, se realiza especuloscopia que objetiva que la sangre proviene del orificio cervical externo y se palpa útero grávido. Se solicitan exámenes, entre los que destaca beta-HCG, que resulta positiva y análisis hematológico, que muestra anemia con hemoglobina de 10 g/dl. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra contenido endometrial de 19mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo?

A) Histerectomía
B) Vaciamiento uterino
C) Ácido tranexámico intravenosa
D) Oxitocina intravenosa
E) Misoprostol intrarrectal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Vaciamiento uterino** (opción **B**). Si la radiografía de tobillo es normal el diagnóstico es esguince; si hay fractura el tratamiento es quirúrgico. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 174 · 3.01.2.006 · Endometritis puerperal

Una paciente de 37 años, puérpera hace 7 días, con antecedente de hemorragia puerperal, evoluciona con aumento de la metrorragia, asociada a fiebre hasta 38,5 grados Celsius y dolor abdominal bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Inercia uterina
B) Neoplasia trofoblástica gestacional
C) Endometritis
D) Restos ovulares
E) Miometritis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Endometritis** (opción **C**). Es una endometritis puerperal clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 151 · 3.01.2.006 · Endometritis puerperal

Una mujer de 25 años, puérpera de 5 días, con parto vaginal, consulta por de aumento de la cantidad de loquios hemáticos y sensación febril. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 110/70 mmHg, examen genital con episiorrafia equimótica y dolor a la palpación uterina. El diagnóstico más probable es:

A) Restos placentarios
B) Neoplasia trofoblástica gestacional
C) Infección de la epifisiorrafia
D) Miometritis puerperal
E) Endometritis puerperal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una endometritis clásica: fiebre, dolor uterino, loquios de mal olor. También puede tener metrorragia. Los restos placentarios solo producen metrorragia tardía, sin dolor ni fiebre (generalmente entre el día 2 y día 4). La NTG suele producir metrorragia tardía, varios días o semanas postparto. La epifisiorrafia equimótica es normal.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 171 · 3.01.2.006 · Endometritis puerperal

Una paciente de 26 años, puérpera de 5 días, presenta fiebre, malestar general y loquios de mal olor. Al examen físico tiene dolor a la palpación y se solicita una PCR, que resulta 9,2 mg/L. Se inicia tratamiento antibiótico con penicilina sódica y gentamicina, sin embargo, dos días después, continúa febril, con dolor y PCR 8,8 mg/L. El agente más probable es:

A) Proteus mirabilis
B) Escherichia coli
C) Bacteroides fragilis
D) Estreptococo betahemolítico grupo B
E) Chlamydia trachomatis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por no haber respondido, lo más probable es que sea un anaerobio (por eso se deja penicilina + gentamicina + clindamicina). Las demás opciones estaban cubiertas con el esquema indicado.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 152 · 3.01.2.006 · Endometritis puerperal

Una paciente de 32 años, cursando puerperio desde hace 8 días, con parto por cesárea, comienza con loquios abundantes y de mal olor, asociada a fiebre. Su examen físico muestra T°: 38,5°C FC: 85x´. PA: 120/80x', herida operatoria sin signos de infección y útero doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar ntibióticos orales
B) Realizar legrado
C) Hospitalizar y manejar con antibióticos endovenosos
D) Realizar histerectomía
E) Administrar una dosis de antibióticos endovenosos y luego manejo ambulatorio con

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Hospitalizar y manejar con antibióticos endovenosos** (opción **C**). Nuevamente es una endometritis, que se trata con antibióticos endovenosos de amplio espectro.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 174 · 3.01.2.006 · Endometritis puerperal

Una paciente se realiza un legrado por un aborto retenido, a las 11 semanas de amenorrea. Cuarto días después evoluciona con dolor hipogástrico y metrorragia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embarazo molar
B) Restos ovulares
C) Embarazo ectópico
D) Endometritis
E) Rotura uterina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy difícil. Tiene una metrorragia postlegrado, cuya primera causa son los restos ovulares (después de 24 horas). Sin embargo, como tiene varios días y en especial porque tiene dolor, la respuesta más correcta es endometritis (los restos ovulares habitualmente no duelen y sangran al otro día).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 141 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente de 32 años con antecedente de síndrome hipertensivo del embarazo, a las 32 semanas no logra cifras tensionales normales a pesar de las medidas no farmacológicas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para continuar con el tratamiento?

A) Losartán
B) Enalapril
C) Nifedipino
D) Espironolactona
E) Doxazosina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Antihipertensivos en el Embarazo: En el embarazo, la mayoría de los antihipertensivos están contraindicados. Los cuatro medicamentos que se pueden usar son alfametildopa, nifedipino (de liberación prolongada o XR), hidralazina y labetalol vía oral (más eficaz, pero su disponibilidad es limitada).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 50 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Embarazada sobre 20 semanas con dolor epigástrico, hipertensión, transaminasas elevadas y trombocitopenia. ¿Diagnóstico más probable?

A) Preeclampsia severa sin criterios de HELLP
B) Síndrome de HELLP
C) Colestasia intrahepática del embarazo
D) Hepatitis aguda viral
E) Hígado graso agudo del embarazo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Síndrome de HELLP** (opción **B**). Síndrome de HELLP. El score de Tal es la herramienta clínica utilizada para evaluar la severidad del síndrome bronquial obstructivo (SBO). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 10 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente de 41 años, embarazada de 24 semanas, tiene una presión arterial de 155/100 mmHg. Los exámenes muestran una proteinuria en 24 horas de 280 mg y el examen físico es normal, sin edema ni signos de preeclampsia severa. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?

A) Iniciar metildopa oral.
B) Iniciar hidralazina intravenosa.
C) Observación y control en 1 semana.
D) Iniciar nifedipino de acción prolongada.
E) Sulfato de magnesio intravenoso.

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar metildopa oral.** (opción **A**). Score de Tal: leve 0-5, moderado 6-8, severo 9-12 puntos (máximo 12) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 28 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

paciente embarazada con hemograma patológico, enzimas hepáticas elevadas, litisis vesicular, hta, hipoglicemia, dolor y fiebre

A) sd hellp o higado graso agudo (en discusión)
B) Hepatitis viral
C) Preeclampsia severa
D) Colestasia intrahepática
E) Hígado graso agudo del embarazo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Embarazada con HELLP + hígado graso agudo del embarazo (HGAE): ambas son emergencias obstétricas con laboratorio similar. En contexto de embarazo con hepatopatía grave, interrupción urgente es la conducta.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 173 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente de 25 años cursando su primer embarazo de 37 semanas acude a control. En el examen Fsico se observa ligero edema de extremidades inferiores y sus signos vitales muestran frecuencia cardíaca de 70 la8dos por minuto y presión arterial de 140/90 mmHg. No ha presentado moles8as y se auscultan la8dos cardiofetales a 125 la8dos por minuto. ¿Qué examen es más adecuado para precisar el diagnós8co?

A) Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas
B) Ecogra:a Doppler renal
C) Ecogra:a obstétrica con Doppler fetal
D) Proteinuria de 24 horas
E) Test de tolerancia a las contracciones

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque dan una única toma, Gene un probable síndrome hipertensivo del embarazo (SHE), que en la práctica corresponde a PA mayor o igual a 140/90 mmHg, que persiste durante una observación de 4 a 6 horas. Por estar en buenas condiciones maternofetales, lo más adecuado es solicitar la proteinuria, a fin de identificar la causa, diferenciando la preclamsia (proteinuria positiva) de la hipertensión gestacional (proteinuria negativa). El edema orienta a preclamsia, pero la proteinuria es lo que la define. También habría sido correcto realizar tomas reiteradas de PA para confirmar el SHE.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 155 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Usted atiende a una paciente de 33 años, con 13 semanas de embarazo. Como antecedentes, tuvo una cesárea de urgencia en un embarazo anterior, a las 31 semanas, por una preclamsia severa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar aspirina
B) Indicar heparina
C) Indicar L-arginina
D) Indicar ácidos grasos omega 3
E) Indicar dexametasona

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Indicar aspirina** (opción **A**). Score de Tal: leve 0-5, moderado 6-8, severo 9-12 puntos (máximo 12) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 100 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente primigesta, cursando un embarazo de 38 semanas, presenta presiones arteriales cercanas a 150/90 mmHg. Está en buenas condiciones generales, sin exaltación neurológica, ni otros síntomas. Se solicita proteinuria de 24 horas, que resulta 400 mg. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar ecodoppler de arterias umbilicales
B) Realizar operación cesárea
C) Solicitar monitoreo fetal no estresante
D) Inducir el parto
E) Repetir la proteinuria en 2 semanas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una preclamsia, que pareciera ser moderada, aunque falta información para estar seguro. De todos modos, por haber llegado al término, se debe interrumpir el embarazo. No hay indicación de cesárea con la información que se entrega. Sin embargo, es una pregunta que induce a error, porque no está de más, evaluar el bienestar fetal antes, ya que en toda paciente con preclamsia debería hacerse un Doppler fetal. Sin embargo, a mi parecer lo correcto es la interrupción, ya que ese es el tratamiento de la preclamsia a las 38 semanas y aunque el Doppler salga normal, igualmente se debe interrumpir.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 48 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente de 25 años, primigesta, cursa un embarazo de 29 semanas. Consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, de localización epigástrica, asociada a vómitos y malestar general. En su examen físico presenta FC: 90x', PA: 147/100 mmHg, FR: 12x', abdomen depresible, doloroso en la palpación epigástrica y más intenso en hipocondrio derecho. Sus exámenes muestran creatinina plasmática: 1,2 mg/dl, electrolitos plasmáticos normales, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 90.000 por mm3, blancos: 12.000 por mm3, LDH: 720 UI/L, PCR: 5,0, bilirrubina: 1,4 mg/dl, SGPT: 248 UI/L y SGOT: 277 UI/L. Su ecografía abdominal muestra cálculos biliares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de HELLP
B) Colecistitis aguda
C) Hígado graso agudo del embarazo
D) Colestasia intrahepática del embarazo
E) Colangitis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto por la presión elevada, como por la anemia, plaquetopenia y elevación de la LDH es un HELLP clásico. Los cálculos biliares solo están como distractor.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 154 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente de 22 semanas de gestación, con embarazo bien controlado, se realiza un doppler de arterias uterinas, que demuestra aumento de la resistencia. Como antecedente, estuvo hospitalizada en un embarazo anterior por una preclamsia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar aspirina
B) Iniciar heparina
C) Iniciar L-arginina
D) Mantener el control normal del embarazo
E) Administrar corticoides

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar aspirina** (opción **A**). Por ser una paciente de alto riesgo, debe recibir profilaxis de PE con aspirina.. Score de Tal: leve 0-5, moderado 6-8, severo 9-12 puntos (máximo 12) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 126 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente de 28 años, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor epigástrico y en hipocondrio derecho, de dos días de evolución, asociado a náuseas y malestar general. Al examen físico se ve decaída, con FC: 105x', PA: 148/99 mmHg, FR: 15x', examen abdominal con dolor a la palpación del epigastrio y el hipocondrio derecho, sin signos peritoneales. Se solicitan exámenes de sangre que muestran hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,9 g/dl, blancos: 6.800 por mm3, plaquetas: 80.000 por mm3, bilirrubina plasmática: 2,0 mg/dl, con fracción indirecta: 1,6 mg/dl y fracción directa: 0,4% GOT: 320 UI/L, GPT: 240 UI/L. La ecografía abdominal muestra presencia de litiasis vesicular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pancreatitis aguda
B) Hepatitis viral
C) Colecistitis aguda
D) Colestasia intrahepática
E) Síndrome de HELLP

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Síndrome de HELLP** (opción **E**). El score de Tal es la herramienta clínica utilizada para evaluar la severidad del síndrome bronquial obstructivo (SBO). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 142 · 3.01.1.011 · Síndrome hipertensivo del

Una paciente de 26 años, multípara de 1, con parto anterior por cesárea, está cursando un nuevo embarazo de 33 semanas, acude a control obstétrico, asintomática y presenta presiones arteriales de 140/90, que no descienden luego de 6 horas de reposo. Además, presenta edema de extremidades inferiores. Se solicita un registro basal no estresante, por 20 minutos, el que se informa como no reactivo. Por ello, se solicita un perfil biofísico que visualiza movimientos respiratorios normales y postura adecuada, con un único bolsillo de líquido amniótico, menor a 1 x 1 cm. Se repite el registro basal no estresante, que vuelve a resultar no reactivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea en este momento
B) Repetir el perfil biofísico en 7 días
C) Realizar test de tolerancia a las contracciones
D) Dejar a evolución espontánea
E) Inducir el parto con misoprostol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar cesárea en este momento** (opción **A**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 177 3.01.2.007 · Hiperemesis gravídica

Una paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentas, desde inicios del embarazo, pero que han ido en aumento. Hace 24 horas ha empeorado, al punto que no ha podido ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia. El diagnóstico más probable es:

A) Gastroparesia gestacional
B) Cólico biliar
C) Hepatitis
D) Hiperemesis gravídica
E) Síndrome de HELLP

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Hiperemesis gravídica** (opción **D**). Es una hiperemesis gravísica clásica.. Gonadotropina coriónica humana (HCG) — principal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 179 3.01.2.007 · Hiperemesis gravídica

Una paciente de 24 años, primigesta de 12 semanas, consulta porque presenta náuseas y vómitos que afectan significativamente su calidad vida. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

A) Corticoides orales
B) Omeprazol oral
C) Doxilamina más piridoxina oral
D) metoclopramida oral
E) Ondasentrón oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Doxilamina más piridoxina oral** (opción **C**). Tratamiento Escalonado De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Corticoides orales, Omeprazol oral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 56 3.01.2.007 · Hiperemesis gravídica

Embarazada con náuseas y vómitos importantes que impactan su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Metoclopramida oral
B) Ondansetrón endovenoso
C) Dieta fraccionada y observación
D) Dimenhidrinato oral
E) Doxilamina y piridoxina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Doxilamina y piridoxina** (opción **E**). Doxilamina y piridoxina. Tratamiento Escalonado De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 178 3.01.2.007 · Hiperemesis gravídica

Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 10 semanas, presenta vómitos frecuentes, que iniciaron hace un mes y han ido en aumento. Además ha bajado 3 kilogramos de peso, desde que se embarazó, ya que muchos de los alimentos y olores le producen muchas náuseas y vómitos. Refiere que vomita cerca de 6 veces al día y que esto afecta claramente su calidad de vida. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Doxilamina
B) Clorpromazina
C) Omeprazol
D) Metoclopramida
E) Ondasentrón sublingual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Doxilamina** (opción **A**). La doxilamina (antihistamínico) son el tratamiento de primera línea en la hiperemesis gravídica.. Tratamiento Escalonado De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 132 3.01.2.015 · Rotura uterina

Puérpera con una cesárea anterior presenta trabajo de parto espontáneo. A las 2 horas de trabajo de parto activo, refiere dolor uterino súbito diferente a las contracciones, y el MEFI muestra bradicardia fetal sostenida. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Fórceps de urgencia
B) Conducción con oxitocina
C) Vacuum
D) Cesárea de urgencia inmediata
E) Espera activa y analgesia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Rotura uterina (dolor súbito diferente a contracciones + bradicardia fetal + antecedente de cicatriz uterina): emergencia obstétrica máxima. Cesárea de urgencia INMEDIATA. El fórceps/vacuum están absolutamente contraindicados. Sin tratamiento puede ser fatal para madre y feto.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 41 3.01.2.015 · Rotura uterina

Embarazada con antecedente de cesárea previa, durante el parto presenta cese de contracciones, sangrado y bradicardia fetal. ¿Diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento prematuro de placenta
B) Placenta previa sangrante
C) Prolapso de cordón umbilical
D) Embolia de líquido amniótico
E) Rotura uterina

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Rotura uterina** (opción **E**). Rotura uterina. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 98 3.01.2.015 · Rotura uterina

Una paciente de 37 años, multípara de 1, cesarizada anterior, presenta un nuevo embarazo de término. Ingresa a la sala de preparto, por contracciones uterinas doloro- sas. Al examen tiene 3-4 contracciones uterinas cada 10 minutos y tacto vaginal con di-

A) Placenta previa
B) Procidencia de cordón
C) Rotura uterina
D) Rotura de vasa previa
E) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una rotura uterina clásica, con el antecedente de cesárea y la clínica habitual (dolor, sufrimiento fetal, escasa metrorragia y útero difícil de palpar).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 51 3.01.2.015 · Rotura uterina

Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 38 semanas, inicia trabajo de parto por lo que es ingresada al hospital. Al examen Fsico presenta cuatro contracciones uterinas cada 10 minutos y se palpa la cabeza fetal encajada, en el tercer plano de Hodge. Durante el parto, evoluciona con metrorragia escasa y dolor abdominal, constatándose elevación de la presentación fetal y cese de las contracciones uterinas. Tiene antecedente de una cesárea previa por podálica a las 39 semanas. El monitoreo fetal muestra descenso de los la8dos cardiofetales a 90 por minuto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Esperar evolución espontánea
B) Realizar cesárea de urgencia
C) Realizar reanimación fetal
D) Administrar tocolí2cos endovenosos
E) Solicitar pH de cuero cabelludo

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un rotura uterina clásica, que se maneja con cesárea inmediata. La cesárea previa es el factor de riesgo más importante.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 166 3.01.2.015 · Rotura uterina

Una paciente de 24 años, multípara de 1, con antecedente de una cesárea previa, por desproporción céfalo pélvica. Cursa con un nuevo embarazo, de término, cuando inicia trabajo de parto. Inicialmente tiene buena dinámica uterina, sin embargo, luego desaparece, agregándose escasa metrorragia. El monitoreo fetal muestra bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento de placenta
B) Rotura uterina
C) Rotura de vasa previa
D) Placenta previa
E) Hipotensión secundaria a la anestesia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una rotura uterina clásica: antecedente de cesárea, contracciones dolorosas que ceden, metrorragia intraparto y sufrimiento fetal.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 167 3.01.2.015 · Rotura uterina

A una paciente se le inserta un DIU en un box de atención ginecológica, pero se sospecha que se produce una rotura uterina. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar analgésicos
B) Solicitar radiografía de pelvis
C) Traccionar las guías del DIU
D) Hospitalizar
E) Citar a control en 48 horas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo primero es localizar el DIU, para saber dónde está (incluso puede estar dentro de un vaso sanguíneo). La localización se hace con ecografía o con radiografía. Luego se ve si se deja o se saca.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 74 3.01.2.015 · Rotura uterina

Una paciente de 39 años, multípara de uno, con nacimiento por cesárea, debido a desproporción cefalopélvica, cursa un nuevo embarazo de 38 semanas de edad gestacional. Comienza con trabajo de parto, por lo que es ingresada a la unidad de preparto, con contracciones uterinas cada 3 minutos y un tacto vaginal que muestra dilatación cervical de 4 cm. Sin embargo, cesan las contracciones uterinas y se produce salida de sangre escasa por vagina, constatándose que el monitor fetal muestra bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Placenta previa
B) Rotura de vasa previa
C) Rotura uterina
D) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
E) Acretismo placentario

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Acretismo placentario** (opción **E**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 48 3.01.2.004 · Eclampsia

Una paciente de 25 años, primigesta con 32 semanas de gestación, presenta cefalea intensa y malestar general. Al examen Fsico destaca una presión arterial de 170/110 mmHg, por lo que se administra labetalol endovenoso, logrando cifras tensionales de 140/90 mmHg. Sin embargo, dos horas después presenta una convulsión tónico-clónica de 2 minutos de duración. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar lorazepam endovenoso
B) Administrar labetalol endovenoso
C) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D) Administrar tocolí2cos endovenosos
E) Realizar maduración pulmonar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una eclamsia, en contexto de una preclamsia severa. El manejo sigue el siguiente orden: 1. Estabilizar a la paciente y 2. Interrumpir el embarazo. La estabilización también Gene un orden: ABC, luego MgSO4 EV y luego labetalol EV si PA >160/110 (en la práctica se hace todo junto). Aunque en la práctica se hace una cesárea, lo correcto académicamente es que la interrupción del embarazo debe privilegiar la vía vaginal (menos sangrado y estrés quirúrgico), a menos que haya signos de sufrimiento fetal, no se pueda estabilizar a la madre o tenga un cuello cerrado y largo (Bishop < 6-7), ya que demoraría mucho el parto, el que idealmente debe ocurrir antes de que pasen 24 horas desde la eclamsia. La maduración pulmonar puede estar indicada en este caso, por tener menos de 34 semanas, pero no alcanzará a hacer efecto (demora 48 horas).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 144 3.01.2.004 · Eclampsia

Una paciente de 25 años, cursando con embarazo de 30 semanas, con antecedente de epilepsia hace 1 año, presenta crisis convulsivas tónico-clónicas, desde hace una hora. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, FC: 87x' y PA: 160/100 mmHg. La ecografía obstétrica muestra feto vivo. ¿Cuál es la primera medida?

A) Administrar nifedipino
B) Administrar fenobarbital
C) Administrar diazepam
D) Administrar sulfato de magnesio
E) Administrar misoprostol

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Aunque haya teido antecedente de epilepsia, el diagnóstico ahora es una eclam- sia, que en primer lugar recibe MgSO4.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 40 3.01.2.004 · Eclampsia

Mujer embarazada de 34 semanas es encontrada convulsionando en la calle. Previamente tenía presión arterial de 165/110 mmHg. Al llegar a urgencias persiste con crisis convulsiva. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Fenitoína IV
B) Sulfato de magnesio IV
C) Diazepam IV
D) Nifedipino sublingual
E) Labetalol IV

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Eclampsia (convulsiones en contexto de preeclampsia): el sulfato de magnesio es el anticonvulsivante de elección (no es un anticonvulsivante clásico, actúa bloqueando NMDA). Fenitoína no tiene evidencia en eclampsia y es teratogénica. Luego control de PA y evaluar interrupción del embarazo.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 105 3.01.2.021 · Trabajo parto distócico

Una paciente de 30 años, mul`para de uno, con antecedente de parto vaginal de recién nacido de 4.000 gramos, cursa nuevo embarazo de término con es8mación de peso fetal de 3.800 gramos. Ingresa en trabajo de parto en fase latente, recibiendo anestesia peridural a los 4 cm de dilatación. Ha permanecido con 6 cm de dilatación en las úl8mas 3 horas y se palpa cabeza fetal en el segundo plano de Hodge, en variante occípito-ilíaca izquierda posterior. Presenta cuatro contracciones uterinas de 50 segundos de duración cada 10 minutos. ¿Cuál es la causa de la demora en el avance de su trabajo de parto?

A) Dinámica uterina insuficiente
B) Distocia de posición
C) Desproporción céfalo-pélvica
D) Macrosomía fetal
E) Distocia de presentación

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene buena dinámica (3-5 contracciones cada 10 minutos). Está en presentación cefálica de vérGce (punto de referencia es el occipucio), así que no hay distocia de presentación. No Gene criterios de macrosomía fetal (mayor a 4.500 gramos). Tiene posición occipital posterior persistente, lo que es compaGble con una distocia de posición. La posición es la rotación del feto en relación a la pelvis (se describe con el punto de referencia, en relación a una parte de la pelvis). La mayoría de los partos se dan en posición anterior: "occipito púbica" u "occipito ilíaca anterior", en cambio, las posiciones transversas y posteriores suelen demorar más y, si persisten, se consideran una distocia de posición. No se debe confundir la posición transversa (ej. occipito ilíaca transversa), que puede demorar, pero Gene opción de parto vaginal, con la con presentación transversa (ej. acromio púbica), que obliga a la cesárea desde el inicio.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 33 3.01.2.021 · Trabajo parto distócico

Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto, con dilatación completa, membranas rotas y buena dinámica. Cuenta con episiotomía mediolateral. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, el resto del cuerpo no progresa, luego de 5 minutos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Ampliar la epifisiotomía
B) Realizar tracción continua por 5 minutos
C) Realizar flexión de las caderas de la madre y realizar compresión suprapúbica
D) Girar el hombro posterior, en el sentido de las agujas del reloj
E) Poner a la madre en posición genupectoral y realizar suave tracción de la cabeza fetal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El manejo de la retención de hombros sigue un orden específico: Primero: realizar hiperflexión de la cadera (maniobra de Mc Roberts). Segundo: realizar compresión suprapúbica (maniobra de Manzzanti / Rubbins). Tercero: intentar rotación del tronco u otra maniobra para sacar el hombro. De no funcionar nada se hacen maniobras más invasivas como sinfisiotomía púbica o fractura de la clavícula fetal.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 168 3.01.2.021 · Trabajo parto distócico

Una paciente de 35 años, está en trabajo de parto de término. Durante el expulsivo, se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo no se produce la rotación ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Traccionar la cabeza fetal
B) Realizar compresiones suprapúbicas
C) Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)
D) Realizar rotación manual de los hombros hacia anterior (maniobra de Rubin)
E) Realizar extracción del brazo posterior (Maniobra de Jacquemier Barnum)

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La maniobra de McRoberts es el manejo de primera línea en la distocia de hom- bros, ya que tiene 90% de éxito y bajísima morbilidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 141 3.01.2.021 · Trabajo parto distócico

Embarazada de 39 semanas en trabajo de parto activo. Lleva 4 horas en fase activa con dilatación cervical detenida en 5 cm, dinámica uterina regular (4 contracciones de 45 segundos cada 10 minutos) y presentación encajada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Fórceps
B) Conducción con oxitocina
C) Espera activa 2 horas más
D) Cesárea de urgencia
E) Vacuum extractor

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Detención de la fase activa con dinámica insuficiente: conducción con oxitocina para aumentar la dinámica uterina. La detención del trabajo de parto sin desproporción cefalopélvica ni sufrimiento fetal NO es indicación de cesárea de inmediato. Primero se intenta conducción activa.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 102 3.01.2.021 · Trabajo parto distócico

Una mujer de 24 años, primípara, en trabajo de parto avanzado. Se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, no se produce la rotación de la cabeza, ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Pivotear la cabeza
B) Realizar compresión de la región suprapúbica (maniobra de Kristeller)
C) Rotar el hombro hacia anterior
D) Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)
E) Realizar fórceps

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El manejo de la retención de hombros es primero la D, luego la B y luego la C, seguido de maniobras más agresivas (fracturar la clavícula del RN, sinfisiotomía púbica).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 62 3.01.2.005 · Embarazo ectópico complica

Mujer joven con dolor súbito en FID, hipotensión y taquicardia súbitas, dolor en ambas fosas ilíacas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda complicada
B) Quiste ovárico torcido
C) Embarazo ectópico roto
D) Salpingitis aguda con absceso tubo-ovárico
E) Rotura folicular hemorrágica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Embarazo ectópico roto** (opción **C**). Embarazo ectópico roto. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 176 3.01.2.005 · Embarazo ectópico complica

Una paciente de 24 años consulta por atraso menstrual de 7 semanas. Se realiza HCG, que resulta 5.000 UI/L, por lo que se hace ecografía transvaginal, que muestra au- sencia de gestación intrauterina y abundante líquido libre peritoneal. ¿Cuál es la con- ducta más adecuada?

A) Realizar curva de HCG
B) Controlar con ecografía transvaginal en 7 días
C) Realizar laparoscopía
D) Administrar metotrexato
E) Mantener el control normal del embarazo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un embarazo ectópico y por tener líquido libre y también más de 3.000 de HCG, es de tratamiento quirúrgico.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 140 3.01.2.005 · Embarazo ectópico complica

Una paciente de 32 años, con amenorrea de 7 semanas y test de embarazo positivo consulta por dolor abdominal bajo intenso. Su examen físico muestra FC: 92x', PA: 110/60 mmHg. Al examen ginecológico tiene útero elástico y sensible y ovarios normales. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra un huevo anembrionado de 13 mm y visualiza una lesión quística de 5 cm, en el ovario derecho.

A) Niveles seriados de HCG
B) Salpingectomía
C) Aspiración manual endouterina
D) Control con ecografía en 7 a 14 días
E) Laparoscopía exploradora ginecológica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy difícil y mal intencionada, ya que no queda claro si están preguntando un huevo anembrionado menor a 25 mm (que se observa y controla con una nueva ecografía en 7 a 14 días) o si es un embarazo heterotópico (es decir, uno normal y otro ectópico), con el embarazo ectópico complicado, caso en el cual habría que hacer una laparoscopía exploradora. Por tener dolor intenso, FC sobre 90 (igual normal en el embarazo), PA de 110/60 (normal también en el embarazo) y la lesión quística en el ovario derecho (que puede ser también el cuerpo lúteo, aunque suele ser sólido-quístico, lo que hace pensar que también pueda ser un embarazo ectópico), creemos que se está preguntando el embarazo heterotópico y se debe proceder a la laparoscopía exploradora, pero solo quien redactó la pregunta sabe realmente qué quería preguntar.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 123 3.01.2.005 · Embarazo ectópico complica

Eco Ginecológica con líquido libre conducta e inestabilidad HD a. Cirugía de urgencia

A) Laparotomía exploratoria
B) Cirugía laparoscópica
C) Manejo conservador
D) Drenaje percutáneo
E) Reparación quirúrgica electiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Laparotomía exploratoria** (opción **A**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 165 3.01.1.031 · VIH en ginecobstetricia

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 32 semanas, sin controles previos, se realiza un Elisa para VIH, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más importante para evitar la transmisión vertical?

A) Iniciar triterapia antirretroviral ahora
B) Realizar cesárea ahora
C) Iniciar triterapia antirretroviral si la carga viral es alta
D) Administrar terapia antirretroviral durante el trabajo de parto
E) Realizar cesárea al llegar a las 38 semanas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La triterapia se inicia a las 20 semanas y es la medida más importante, ya que baja la carga viral, que es el predictor de trasmisibilidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 33 3.01.1.031 · VIH en ginecobstetricia

Una paciente, con antecedente de parto hace 3 meses, realizado por cesárea, VIH positivo, en tratamiento antirretroviral, con cargas virales indetectables y sin lactancia materna, consulta por un tratamiento anticonceptivo. ¿Cuál es el método de elección?

A) Anticonceptivos orales combinados
B) Anticonceptivos orales con progestágeno solo
C) Anticonceptivos orales con estrógeno solo
D) Preservativo
E) Dispositivo intrauterino

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Preservativo** (opción **D**). Por el VIH está obligada a usar métodos de barrera.. Diagnóstico VIH: ELISA (screening) + Western Blot (confirmación), ambos miden anticuerpos. En periodo de ventana y recién nacido de madre VIH: usar PCR o antígeno P24. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 85 3.01.1.003 · Colestasia gravídica

Una paciente de 25 años, con 33 semanas de embarazo, consulta por prurito de predominio palmo-plantar, pero que en ocasiones es generalizado. Refiere que es más intenso en la noche. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Transaminasas
B) Ecografía abdominal
C) Ácidos biliares
D) Fosfatasas alcalinas
E) Bilirrubina total y diferenciada

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El diagnóstico de la colestasia intrahepática es clínico y no requiere de exámenes. Sin embargo, las fosfatasas alcalinas se elevan con mucha frecuencia, mientras que la bilirrubina puede ser normal.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 46 3.01.1.003 · Colestasia gravídica

Una paciente de 34 años, cursando embarazo de 32 semanas inicia prurito de palmas y plantas, que es más intenso en la noche y se asocia a astenia y vómitos. Al examen físico tiene signos vitales normales y se constata leve ictericia de escleras, sin alteraciones en las extremidades ni lesiones cutáneas. Su altura uterina es de 27 cm. Se solicitan exámenes, entre los que destacan bilirrubina: 1,5 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 411 UI/L, SGOT: 32 UI/L, SGPT: 38 UI/L, gamaglutamiltransferasa: 398 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Colestasia intrahepática
B) Colangitis biliar primaria
C) Ictericia por hiperémesis gravídica
D) Hígado graso agudo del embarazo
E) Coledocolitiasis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una colestasia intrahepática del embarazo clásica, cuyo diagnóstico es clínico. En este caso, además trae pruebas hepáticas con un patrón colestásico, aunque pueden estar normales, por lo que el examen de elección para complementar la sospecha clínica son los niveles de ácidos biliares.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 153 3.01.1.003 · Colestasia gravídica

Mujer cursando embarazo de 37 semanas, consulta por prurito palmo-plantar. En los exámenes destacan ácidos biliares de 110- 112, conducta:

A) Interrupción del embarazo
B) Ácido ursoderxecolico
C) Antihistamínicos 154. Paciente con sd nefrotico y hipergammaglobulinemia policlonal, complemento bajo. Diagnóstico:
A) Lupus
B) Amiloidosis

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Interrupción del embarazo** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 86 3.01.1.003 · Colestasia gravídica

Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 33 semanas, consulta por malestar general, asociado a dolor en el hipocondrio derecho, que ha aumentado. Además, tiene astenia, náuseas, y cefalea. Su examen físico muestra FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, edema de extremidades inferiores y abdomen doloroso en el hipocondrio derecho, palpándose el hígado bajo el reborde costal. Entre sus exámenes destacan glicemia: 58 mg/dl, creatinina plasmática: 1,1 mg/dl, plaquetas: 120.000 por mm3, LDH: 420 UI/L y PCR: 3 (VN: menor a 1). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de HELLP
B) Hepatitis viral
C) Hígado graso agudo del embarazo
D) Colestasia intrahepática del embarazo
E) Coledocolitiasis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La astenia, la hipoglicemia y la clínica inespecífica son clásicas del hígado graso agudo del embarazo. No es HELLP, a pesar de la LDH alta, por la PA normal.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 53 · 3.01.1.003 · Colestasia gravídica

Una paciente de 32 años, primigesta cursando un embarazo de 36 semanas, sin antecedentes de importancia, consulta por un cuadro de 7 días de evolución de dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho, que se asocia a náuseas y malestar general. Al examen físico, tiene temperatura: 37°C, presión arterial: 100/70 mmHg, FC: 92x' y, al examen abdominal, presenta dolor a la palpación del hipocondrio derecho. Su examen obstétrico muestra ausencia de contracciones uterinas, con altura uterina de 33 cm, feto en cefálica, con latidos cardiofetales a 120x'. Se solicitan exámenes de sangre, entre los que se muestran hematocrito: 32%, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 99.000 por mm3, glóbulos blancos: 12.000 por mm3, VHS: 26 mm/h, glicemia: 56 mg/dl, GOT: 250 UI/L, GPT: 220 UI/L, bilirrubina total: 5,5 mg/dl de predominio directo y protrombinemia: 60%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hígado graso agudo del embarazo
B) Hepatitis viral
C) Colestasia intrahepática del embarazo
D) Síndrome de HELLP
E) Colangitis biliar primaria

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hígado graso agudo del embarazo (HGAE): Esta complicación generalmente aparece en el tercer trimestre del embarazo. Se caracteriza por astenia, náuseas, signos de hepatitis, y una tendencia a desarrollar insuficiencia hepática e hipoglicemia. El síndrome de HELLP comparte algunas características y se caracteriza por la presencia de anemia, transaminasas elevadas y plaquetopenia, que se ven en este caso, pero también se pueden ver en el HGAE. La presencia de hipoglicemia y la presión arterial normal orienta más a HGAE.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 47 · 3.01.1.003 · Colestasia gravídica

Una paciente de 32 años, cursando un embarazo de 33 semanas, consulta por malestar general, asociado a dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho de 3 días de evolución, que ha aumentado. Además, tiene astenia, cefalea y náuseas, asociadas a algunos episodios de vómitos alimentarios. Su examen físico muestra FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, edema de extremidades inferiores y abdomen doloroso en el hipocondrio derecho, palpándose el hígado bajo el reborde costal. Entre sus exámenes destacan glicemia: 58 mg/dl, creatinina plasmática: 1,3 mg/dl, hemoglobina: 10,6 g/dl, plaquetas: 110.000 por mm3, LDH: 420 UI/L, PCR: 3 (VN: menor a 1), bilirrubina: 2,8 mg/dl, SGPT: 260 UI/L y SGOT: 340 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de HELLP
B) Hepatitis viral
C) Hígado graso agudo del embarazo
D) Colestasia intrahepática del embarazo
E) Coledocolitiasis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un HGAE clásico. Si bien tiene anemia y plaquetopenia, característicos del HELLP, su presión arterial es normal y la astenia e hipoglicemia sugieren muy fuertemente un HGAE.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 176 · 3.01.2.009 · Mastitis puerperal

Una paciente de 34 años, puérpera hace 15 días, dando lactancia materna, presenta dolor en la mama derecha, de 3 días de evolución, que ha aumentado y se ha acompañado de eritema y malestar general. Al examen físico tiene FC: 78x', PA: 120/82 mmHg, T°: 38,0°C y se observa mama derecha dolor a la palpación de los cuadrantes superiores, los que se palpan indurados y con aumento de la temperatura local, asociado a eritema de la piel de dicha zona. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar drenaje mamario quirúrgico
B) Suspender la lactancia materna
C) Iniciar antibióticos
D) Indicar analgésicos
E) Aplicar frío local y luego calor local, alternadamente

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una mastitis puerperal, por lo que solo se deben indicar antibióticos con cobertura de gram positivos (cefazolina endovenosa o amoxicilina + ácido clavulánico oral). Si hubiese tenido un absceso, pues, además se drena. No es necesario suspender la lactancia, sino mejorar la técnica de lactancia.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 153 · 3.01.2.009 · Mastitis puerperal

Una paciente de 24 años, puérpera de 15 días, presencta dolor en la mama derecha, asociada a eritema, aumento de la temperatura local y fiebre hasta 38,8°C. Al examen físico se aprecia mama derecha eritematosa y congestiva, dolorosa a la palpación, sin zonas fluctuantes. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Antiinflamatorios
B) Compresión con frío local
C) Suspender la lactancia materna
D) Drenaje mamario
E) Antibióticos orales

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una mastitis aguda, que se trata con antibióticos, generalmente endovenosos, aunque si está bien se puede tratar con antibióticos orales (generalmente amoxicilina con ácido clavulánico, aunque también se pueden dar otros fármacos que cubran S. aureus).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 170 · 3.01.2.009 · Mastitis puerperal

Una paciente de 30 años, púerpera de 28 días, en lactancia materna, consulta por dolor en la mama derecha, asociado a fiebre hasta 38,5°C. Al examen tiene aumento de volumen y eritema zona superior derecha de la mama, con aumento de volumen palpable, de consistencia aumentada y dolorosa, de 4 cm de diámetro, no fluctuante ni renicente (una palabra inventada por quien hizo esa pregunta), ubicado en el cuadrante superoexterno de dicha mama. El diagnóstico más probable es:

A) Congestión mamaria
B) Flegmón mamario
C) Absceso mamario derecho
D) Mastitis derecha
E) Cáncer inflamatorio de mama

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por no ser fluctuante, parece un flegmón mamario. Aunque en estricto rigor igual es una mastitis. Sin embargo, se hacía mucho hincapié en la lesión no fluctuante, por lo que dejaremos flegmón como respuesta correcta. Es una mala pregunta.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 59 3.01.1.007 · Embarazo múltiple

Una paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Se encuentra en buenas condiciones generales, sin síntomas. Al examen tiene signos vitales normales y su ecografía obstétrica muestra al primer gemelo creciendo con una estimación de peso fetal de 2.850 gramos y al segundo gemelo con una estimación de 2.750 gramos, con líquido amniótico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar control ecográfico en una semana
B) Programar cesárea electiva a las 38 semanas
C) Inducir el parto de inmediato
D) Solicitar ecografía Doppler de arterias uterinas
E) Realizar cesárea de urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Embarazo gemelar bicorial biamniótico: En un embarazo gemelar bicorial biamniótico sin complicaciones, la ecografía muestra fetos con pesos similares y sin restricción del crecimiento intrauterino (por encima del percentil 10). Se suele interrumpir a las 38 semanas. La vía del parto depende de la presentación del primer gemelo y la amniocidad. Si el primer gemelo está en posición cefálica y es biamniótico, se puede realizar un parto vaginal (tanto en monocorial como en bicorial). En cambio, si el primer gemelo no está en posición cefálica o si es monoamniótico, se interrumpe por cesárea. Los monocoriales biamnióticos, se interrumpen a las 36 semanas. Los monoamnióticos, a las 32 a 34 semanas.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 54 3.01.1.007 · Embarazo múltiple

Una paciente de 34 años, cursando su primer embarazo, gemelar, bicorial biamniótico, de 26 semanas de edad gestacional. Se controla con ecografía obstétrica, que visualiza un gemelo muerto, sin compromiso hemodinámico del gemelo sobreviviente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar extracción del feto muerto
B) Realizar controles periódicos con dímero D
C) Interrumpir el embarazo
D) Realizar cesárea a las 37 semanas
E) Realizar controles periódicos con pruebas de coagulación

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy difícil, pero el manejo de un gemelo muerto depende de la edad gestacional y de la corionicidad. En el primer trimestre siempre se observa evolución, porque no hay nada más que hacer. En el segundo y tercer trimestre los monocoriales se tienen a interrumpir, ya que si uno muere, el otro también, a menos que se pueda hacer alguna otra intervención intrauterina (si muy prematuro). ´En los bicoriales, en cambio, se puede observar, pero existe el riesgo de sufrimiento fetal y de coagulación intravascular diseminada. Por tanto, se sigue con pruebas de bienestar fetal y con pruebas de coagulación, ya que, a pesar de que el DD es el examen con el que habitualmente se diagnostica la CID, en el embarazo el CID se altera per sé y, por ello, se usan las pruebas de coagulación (que se alargan en la CID).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 143 3.01.1.007 · Embarazo múltiple

ecografía-doppler, que muestra discordancia de crecimiento de 28%, perfil biofísico tranquilizador y doppler con aumento de la resistencia umbilical y flujo presente en diástole. Ambos fetos se encuentran en posición cefálica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea ahora
B) Inducir el parto ahora
C) Realizar control seriado con doppler fetal
D) Administrar corticoides antenatales
E) Repetir el perfil biofísico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene gemelos discordantes (uno es 25% más chico que el otro), que, aunque la mayoría además cumple con que uno de ellos es RCIU, en este caso no se menciona. De todos modos, el manejo es similar al RCIU. En este caso, tiene un doppler con alteraciones, pero, de baja gravedad (aumento de la resistencia), ya que aún hay flujo en diástole. Por tanto, no es necesario interrumpir aún y se debe seguir con el Doppler. Eso sí,

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 97 3.01.1.009 · Macrosomía fetal

Embarazo 38 sem 4300g cesárea previa a las X sem por desproporción cefalo pélvica (guagua pesaba 3900). Conducta:

A) cesarea inmediata
B) programar cesarea 39 semanas
C) esperar inicio tdp
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **cesarea inmediata** (opción **A**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 40 3.01.1.009 · Macrosomía fetal

Una paciente de 32 años ingresa en trabajo de parto con 38 semanas de gestación. Al examen obstétrico, presenta buena dinámica uterina y se palpa feto en presentación cefálica apoyada y dilatación cervical de 3 cm. El peso fetal es8mado es de 4.200 g. Tiene antecedente de un parto vaginal previo a las 39 semanas, con retención de hombros y un peso al nacer de 3.900 g. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Conducir el trabajo de parto
B) Iniciar goteo oxitócico
C) Administrar tocolí2cos
D) Realizar cesárea en este momento
E) Determinar la vía de parto una vez completada la dilatación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy discuGble. Actualmente está en trabajo de parto, por lo que se debe elegir entre hacer una cesárea o dejar a evolución espontánea. El antecedente de distocia de hombros previa aumenta el riesgo de una nueva retención de hombros, pero no es indicación absoluta de cesárea. Por el contrario, la mayoría de las guías internacionales plantean conversarlo con la paciente y determinar la vía de parto de manera conjunta e individualizada. Sin embargo, en el caso concreto, en que pesa 300 gramos más que en el parto anterior con retención de hombros, parece del todo razonable hacer una cesárea.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 98 3.01.1.005 · Embarazo con edad gestacio

Mujer con reglas irregulares, test de embarazo +, fur no confiable pero si segura, amenorrea de 10 semanas. Como saber edad gestacional:

A) longitud cefalo- caudal
B) longitud saco gestacional
C) niveles bcg
D) FUR segura
E) Interrupción del embarazo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (longitud cefalo- caudal). 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (longitud saco gestacional, niveles bcg) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 53 3.01.1.002 · Anemia y embarazo

Embarazada de 20 semanas con hemoglobina de 9.0 g/dL, VCM 72 fL (microcítica), ferritina 8 ng/mL. Sin síntomas. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Hierro oral elemental 200 mg/día
B) Transfusión de glóbulos rojos
C) Hierro endovenoso
D) Vitamina B12 intramuscular
E) Ácido fólico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Anemia ferropénica en embarazo (Hb <11 g/dL + microcitosis + ferritina baja): tratamiento de primera línea = hierro oral elemental 200 mg/día. Hierro EV se reserva para intolerancia oral, malabsorción o anemia severa. Transfusión solo en anemia grave sintomática.

GINECOLOGÍA & ONCOLOGÍA

Módulo 3: Materno - Infantil · Colección Tomo 20

246 PREGUNTAS REALES
CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

47 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.1.012	Amenorrea	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 19 · 19.20 (Pág. 72)
3.01.1.013	Cáncer cervicouterino	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.015	Endometriosis	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.016	Enfermedad preinvasora del cuello uterino-Lesiones	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	15 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.017	Enfermedades de transmisión sexual	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.018	Hemorragia genital anormal	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	11 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.019	Infecciones genitourinarias	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	15 Q	Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30)
3.01.1.020	Infertilidad conyugal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.021	Mioma uterino	Dx: **Sospecha** · Tx: **Completo**	8 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.023	Patología benigna del endometrio	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	12 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.024	Patología maligna del endometrio	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	11 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.025	Proceso inflamatorio pelviano	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.026	Prolapso genital	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.027	Síndrome climatérico y menopausia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	18 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.028	Tumores ováricos	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.029	Patología benigna de mama	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.030	Cáncer de mama	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.1.032	Incontinencia urinaria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.002	Absceso glándula de Bartolino	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	7 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.008	Hemorragia genital aguda (metrorragia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.016	Dolor pélvico agudo	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.018	Pelviperitonitis	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.2.019	Quiste ovárico torcido	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.020	Mastitis abscedada	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.001	Control prenatal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	14 Q	Tomo 19 · 19.1 (Pág. 5)
3.01.3.002	Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.003	Determinación de edad gestacional	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.004	Lactancia	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.005	Manejo de la salud de la mujer climatérica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.008	Anticoncepción	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	12 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.009	Prevención de enfermedad hemolítica perinatal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.010	Prevención de enfermedades de transmisión sexual	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.011	Pubertad (adolescencia)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.013	Screening ginecológico: Papanicolau, mamografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.015	Síndrome de ovario poliquístico	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.4.001	Histerosalpingografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.4.002	Mamografía	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.4.004	Ecotomografía obstétrica patológica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.4.006	Ecotomografía mamaria	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.4.007	Papanicolau	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.5.005	Evaluación anteparto	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.5.006	Evaluación intraparto	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.5.009	Monitorizacion fetal (estresante y no estresante)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · 19.3 (Pág. 9)
3.01.5.010	Parto normal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.5.011	Perfil biofisico fetal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.5.012	Prueba de trabajo de parto	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.5.013	Taponaje vaginal	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 44 3.01.3.008 · Anticoncepción

Paciente que tuvo relaciones sexuales hace 96 horas sin protección, solicita anticoncepción de emergencia. ¿Qué indicar?

A) Mifepristona 200 mg vía oral dosis única
B) DIU de cobre inmediato
C) Ulipristal acetato 30 mg vía oral
D) Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral
E) Etinilestradiol 50 mcg + levonorgestrel (Yuzpe)

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral). Levonorgestrel 0,750 mg cada 12 horas vía oral. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 171 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una mujer de 36 años, multípara de 3, con su último parto hace 3 años, tiene antecedente personal de cáncer de mama, que fue adecuadamente tratado hace 1 año. ¿Qué método de planificación familiar debe utilizar?

A) Anticonceptivos orales combinados, con microdosis de estrógeno
B) Anticonceptivos orales con estrógeno solo
C) Progestágeno inyectable
D) Anillo vaginal con progestágeno
E) Dispositivo intrauterino

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por tener antecedente personal de cáncer de mama tiene absolutamente contraindicados todos los métodos hormonales. El DIU es la indicación.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 172 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una paciente de 20 años, nuligesta, presentó relaciones sexuales sin protección hace 72 horas. Consulta porque quiere contracepción de emergencia. ¿Cuál es la más efectiva?

A) Levonorgestrel 0,75 mg por una vez
B) Levonorgestrel 0,75 mg ahora y 0,75 mg en 12 horas
C) Método Yuzpe
D) Anillo vaginal
E) T de cobre

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (T de cobre). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Levonorgestrel 0,75 mg por una vez, Levonorgestrel 0,75 mg ahora y 0,75 mg en 12) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 10 3.01.3.008 · Anticoncepción

Anticoncepción en mujer con HTA reciente diagnóstico IMC 34 que tomaba ACO combinado hace 10 años:

A) Estrógenos vo
B) Estrógenos intradérmicos c. Progestágenos vo
D) Reducir dosis estrógenos
E) Anillo vaginal SIIII YO PUSE ESO
E) Hemograma y VHS

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Estrógenos intradérmicos c. Progestágenos vo** (opción **B**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 19 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una paciente de 22 años, nulípara, con antecedentes de migraña a repetición y un episodio de aumaurosis fugax desea iniciar un método anticonceptivo. Su examen físico se encuentra normal. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos indicaría a esta paciente?

A) Anticonceptivos combinados por vía oral
B) Anticonceptivos combinados por vía transdérmica
C) Salpingoligadura
D) Dispositivo intrauterino con progestinas
E) Anticonceptivos combinados inyectables

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy difícil, ya que por ser nulípara tiene contraindicación relativa del DIU, sin embargo por tener jaqueca con amaurosis fugax, están contraindicados absolutamente los estrógenos, ya que los ACO están contraindicados en algunas jaquecas con mayor riesgo de AVE: la amaurosis fugax es uno de los criterios de contraindicación absoluta. Además la salpingoligadura es irreversible. Esta pregunta es muy muy difícil y debería anularse, ya que todas las opciones están contraindicadas; la del DIU medicado es la más aceptable.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 45 3.01.3.008 · Anticoncepción

Paciente con hijo de 8 meses, aún en lactancia. ¿Cuál es el método anticonceptivo más adecuado?

A) Anticonceptivos orales combinados
B) Dispositivo intrauterino con levonorgestrel
C) Anillo vaginal mensual
D) Parche anticonceptivo transdérmico
E) Implante subdérmico de etonorgestrel

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Dispositivo intrauterino con levonorgestrel). Dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 164 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una paciente de 23 años, usuaria de anticonceptivos orales, desde hace 8 meses, consulta por cefalea intensa premenstrual, de 3 meses de evolución, y que dura hasta el segundo día de la menstruación. Su examen físico y neurológico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Anticonceptivos combinados orales de ciclo extendido
B) Anticonceptivos combinados con menor dosis de estrógeno
C) Anticonceptivos combinados con menor dosis de progestágeno
D) Indicar anticonceptivos orales de progestágeno solo
E) Indicar anticonceptivos combinados inyectables

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una cefalea que aparece al suspender los estrógenos (cefalea catamenial), por lo que se debe usar un esquema continuo (sin días de descanso) o bien los ACO de ciclo extendido, que mantienen cierta dosis de estrógeno durante todo el ciclo. Los anticonceptivos inyectables también parecen una opción razonable para ese fin (en especial los trimestrales de progestágeno puro), pero producen aumento de peso y problemas menstruales. Otra forma es bajar la dosis de estrógeno y reducir los días de descanso (ej. esquema de 24 días con dosis más baja de estrógeno y solo 4 días de descanso). Con todo, la respuesta mejor parece la de ACO de ciclo extendido.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 79 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una paciente de 30 años, multípara de 2, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento, es usuaria de DIU desde hace 8 años y presenta hipermenorrea y dismenorrea de 8 meses de evolución, por lo que quiere cambiar de método anticonceptivo. ¿Cuál de las siguientes opciones es de elección?

A) DIU medicado con progestágeno
B) Anticonceptivos orales combinados
C) Anillo vaginal combinado
D) Progestágenos inyectables cada 3 meses
E) Estrógeno solo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El DIU medicado no produce la hipermenorrea y dismenorrea del DIU común. Además, tiene el mejor perfil cardiovascular, en relación a los métodos hormonales.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 171 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una mujer de 32 años, con antecedente de parto hace 8 meses, sigue dando lactancia materna a su hijo y se ha mantenido en amenorrea. No quiere embarazarse todavía, por lo que pregunta cuál es el método anticonceptivo de elección:

A) Amenorrea de la lactancia
B) Anticonceptivos orales combinados de etinilestradiol y dienogest
C) Anticonceptivos en parches de norelgestromina y etinilestradiol
D) Anticonceptivos inyectables de medroxiprogesterona y estradiol
E) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel). 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Amenorrea de la lactancia, Anticonceptivos orales combinados de etiniles) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 78 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una paciente de 28 años, con antecedente de IMC: 29 y resistencia a la insulina, usuaria de DIU desde hace 5 años, presenta reglas abundantes y dismenorrea, por lo que solicita cambiar a anticoncepción oral. ¿Cuál de las siguientes opciones es la de elección?

A) Etinilestradio 0,02 mg, más drospirenona 3 mg
B) Etinilestradio 0,03 mg, más gestodeno 75 ug
C) Etinilestradio 0,03 mg, más dienogest 3 mg
D) Estradiol 2 mg, más dienogest 2 mg
E) Gestodeno 75 ug

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

[Pregunta disputada] Pregunta muy discutible, pero el ACO que controlar mejor el sangrado, de los que ahí están sería los que tienen etinilestradiol (en lugar de estradiol) con dienogest, que, además, tiene un excelente perfil cardiovascular. Es una pregunta que excede lo que debe saber un médico general

---

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 173 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una paciente de 23 años, usuaria de anticonceptivos orales, desde hace 8 meses, consulta por cefalea intensa, que inicia 3 días antes de la menstruación y que dura hasta el segundo día de la menstruación. Refiere que la cefalea se asocia a visión de destellos de luces. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Anticonceptivos orales de ciclo extendido
B) Disminuir la dosis de estrógeno
C) Disminuir la dosis de progestágeno
D) Indicar anticonceptivos orales de progestágeno solo
E) Indicar anticonceptivos combinados inyectables

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una jaqueca premenstrual, que se desencadena por la caída de los niveles de estrógeno. Por ello, se indican ACO de ciclo extendido, que tienen niveles más homogéneos de estrógeno. Sin embargo, la evidencia dice que se debe tratar como toda jaqueca común y corriente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 180 3.01.3.008 · Anticoncepción

Una paciente de 48 años, usuaria de DIU hace 8 años, consulta por reglas irregula- res. Su FUR fue hace 50 días y no refiere otros síntomas. En la especuloscopía, no es po- sible visualizar las guías del DIU. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar radiografía pélvica
B) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, prolactina, FSH y LH
C) Realizar ecotomografía pelviana
D) Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta-HCG
E) Intentar exploración uterina con pinza, para extraer el DIU

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar niveles plasmáticos de subunidad beta-HCG** (opción **D**). Lo primero siempre es descartar embarazo.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 25 3.01.5.009 · Monitorizacion fetal (estr

Una mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico es normal. Se solicita registro basal no estresante de veinte minutos que se muestra a continuación: La conducta más adecuada en este caso es:

A) Tranquilizar a la paciente e indicar que mantenga controles habituales
B) Solicitar perfil biofísico
C) Solicitar ecografía obstétrica
D) Repetir registro basal no estresante por veinte minutos más
E) Realizar test de tolerancia a las contracciones uterinas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un RBNE no reactivo (solo tiene dos desaceleraciones pequeñas, con mínimas aceleraciones. Se debe alargar por 20 min más. Para ser reactivo requiere 2 aceleraciones de 15 lpm de amplitud y de 15 seg de duración.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 58 3.01.5.009 · Monitorizacion fetal (estr

Disminución de los movimientos fetales de 12 horas de evolución con LCF (+) conducta: a. RBNE

B) Test de tolerancia a las contracciones
B) Interrupción del embarazo
C) Maduración pulmonar y observación
D) Cesárea de urgencia
E) Inducción del parto

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Test de tolerancia a las contracciones, Interrupción del embarazo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 43 3.01.5.009 · Monitorizacion fetal (estr

Embarazada 36 semanas, cesárea previa, disminución de MF, RBNE no reactivo, bolsillo de LA 1x1 cm, Bishop 3. ¿Cuál es la conducta?

A) Interrumpir por cesárea
B) Maduración cervical con misoprostol e inducción
C) Hospitalizar y repetir PBF en 24 horas
D) Administrar betametasona y esperar 48 horas
E) Corticoide pulmonar y control ambulatorio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Interrumpir por cesárea** (opción **A**). Interrumpir por cesárea. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 84 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 38 años, multípara de 4, con antecedente de 5 abortos, que requirieron de legrado, nota disminución progresiva del flujo menstrual, hasta haber caído en amenorrea, desde hace 100 días. Su examen físico no muestra alteraciones y no utiliza métodos anticonceptivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Asherman
B) Menopausia precoz
C) Hiperprolactinemia
D) Síndrome de ovario poliquístico
E) Hipopituitarismo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Síndrome de Asherman: El caso corresponde a un síndrome de Asherman clásico, también llamado sinequias uterinas, causado por un legrado uterino. En la ecografía transvaginal se suele ver con endometrio fino. Se trata con cirugía.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 25 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 33 años consulta porque desde hace 95 días que no ha menstruado. Sus reglas previas eran regulares, es sexualmente activa y usa preservativo como método anticonceptivo. Hace dos semanas se realizó un test de embarazo en orina, que resultó negativo. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Subunidad beta HCG
B) Niveles plasmáticos de FSH
C) Ecografía transvaginal
D) Niveles plasmáticos de prolactina
E) Niveles plasmáticos de TSH

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Estudio de la amenorrea: El estudio de la amenorrea debe comenzar descartando el embarazo. Aunque la paciente se realizó una prueba de embarazo en orina hace dos semanas, es recomendable iniciar el estudio con una nueva prueba de embarazo, antes de continuarla con TSH, prolactina y FSH (en la práctica se pide todo junto).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 115 3.01.1.012 · Amenorrea

Una mujer de 27 años, nulípara, usuaria de anticonceptivos orales por seis años, consulta por amenorrea de cinco meses de evolución, no asociado a otros síntomas. Su examen físico es normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Solicitar niveles de prolactina, tirotropina, hormona folículoestimulante y estrógenos
B) Solicitar prueba de estrógeno y progesterona
C) Indicar anticonceptivos orales combinados
D) Observar evolución por un año
E) Indicar uso de agonistas de las gonadotrofinas y controlar en un mes

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Prolactina, TSH es lo más importante. La FSH y estrógenos se piden después, pero es la opción más correcta. DE todos modos, el test de embarazo debería ser lo primero, luego TSH y PRL y luego la prueba de progesterona.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 18 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 17 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución. Su examen físico no muestra alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:

A) Macroadenoma hipofisiario
B) Falla ovárica primaria
C) Embarazo ectópico
D) Amenorrea hipotalámica
E) Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La prueba de progesterona (-) descarta anovulación. La prueba de estrógeno más progesterona (+) confirma un hipogonadismo. La LH y FSH en el límite bajo, muestra que es un hipogonadismo hipogonadotrópico, que son por causas hipofisiarias o hipotalámicas: "el hipo hipo es hipo hipo".

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 89 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 32 años consulta por amenorrea de 5 meses de evolución. Se realiza múltiples exámenes, entre los que destacan HCG: < 5 UL/L, FSH y LH < 5 UI/L, con pruebas tiroides y prolactina dentro de rangos normales. Su prueba de progesterona es negativa y su prueba de estrógeno más progesterona es positiva. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de ovario poliquístico
B) Falla ovárica primaria
C) Síndrome de Asherman
D) Falla hipotalámica / hipofisiaria
E) Disgenesia gonadal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

PP negativa descarta anovulación (A); PE+P negativa confirma hipogonadismo; FSH y LH muy bajas muestran que es hipogonadotrópico y, por tanto, hipotalámico o hipofisiario. La B sería hipergonadotrópico. La C sería uterino, por lo que sus exámenes hormonales serían todos normales y tanto la PP como la PE+P estarían negativas.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 113 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 18 años consulta por amenorrea primaria. Refiere que inició su vida sexual hace algunos meses, pero presenta dolor durante la penetración. En su examen Fsico 8ene desarrollo mamario y puberal normal, con genitales externos femeninos sin alteraciones. Se realiza especuloscopía y se observa vagina corta y estrecha, sin poder visualizar el cuello uterino. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar cariograma
B) Solicitar ecogra:a pélvica
C) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis
D) Solicitar niveles plasmá2cos de estrógeno, progesterona, FSH y LH
E) Iniciar an2concep2vos orales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Se debe estudiar con una ecografía pélvica, tanto por tener una amenorrea primaria (cuyo estudio inicia con ecografía), como por la vagina corta (que hace sospechar una agenesia mulleriana, que también se estudia con ecografía, la que muestra ausencia de útero). En caso de que no se identifique el útero, se sigue el estudio con cariograma, para diferenciar la agenesia mulleriana (46XX) de la insensibilidad a los andrógenos (46XY). Vale la pena mencionar que el desarrollo mamario y puberal normal hace poco probable una alteración hormonal.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 32 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 36 años, multípara de 3, con historia de amenorrea desde hace 4 meses, no asociado a otros síntomas. Refiere haber sido usuaria de anticonceptivos orales hasta hace 6 meses y que se realizó test de embarazo en dos oportunidades con resultado negativo. Se solicitan niveles de hormona tiroestiumlante y prolactina que resultan normales, además prueba de progesterona que es negativa, por este motivo se solicita prueba de estrógeno más progesterona que resulta positiva y niveles de hormona folículo estimulante que resulta en 5 mUI/mL. El diagnóstico más probable es:

A) Falla ovárica primaria
B) Falla del eje hipotálamo hipofisiario
C) Síndrome de ovario poliquístico
D) Malformación uterina
E) Síndrome de cushing

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un hipogonadismo (PP negativa, con PE+P positiva) hipogonadotrópico (FSH baja), por lo que es un problema hipotalámico (tendría GnRH baja) o hipofisiario (tendría GnRH alta).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 131 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 15 años, con menarquia a los 14 años, consulta por atraso mens- trual de 2 meses. No tiene vida sexual. Su examen físico segmentario no muestra altera- ciones y tiene desarrollo mamario y genital acorde a su edad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Pedir niveles plasmáticos de TSH y prolactina
B) Solicitar ecografía transvaginal
C) Realizar histerosonografía
D) Iniciar anticonceptivos orales
E) Dar progesterona oral, si el atraso dura un mes más

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Sería una amenorrea secundaria, probablemente por anovulación. Aunque nie- gue vida sexual, lo primero es un test de embarazo. Luego, en adolescentes, se hace la prueba de progesterona, si es que alcanza a hacer amenorrea de 3 meses. Sin embargo, no se debe olvidar que dentro de los 2 primeros años post menarquia es normal tener todo tipo de alteraciones menstruales.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 59 3.01.1.012 · Amenorrea

Usuaria de DIU hace 5 años, amenorrea de 8 meses y galactorrea bilateral, examen ginecológico normal. ¿Qué solicitar?

A) β-HCG sérico
B) Ecografía transvaginal
C) FSH y LH
D) Prolactinemia
E) TSH y T4 libre

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Prolactinemia). Prolactinemia. 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (β-HCG sérico, Ecografía transvaginal) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 12 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 45 años, usuaria de anticonceptivos orales, suspende los ACO, presentando amenorrea de 4 meses. Se solicitan exámenes, que muestran TSH: 3,7 UI/L, prolactina normal, FSH: 60 UI/L (VN < 40), estradiol: 13 pg/ml (VN: 25 – 75). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de ovario poliquístico
B) Hipogonadismo hipergonadotrópico
C) Atrofia endometrial por anticonceptivos
D) Hipogonadismo hipogonadotrópico
E) Síndrome de Asherman

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una menopausia normal (mayor a 40 años), que es un hipogonadismo (estrógenos bajos) hipergonadotrópico (FSH alta).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 2 3.01.1.012 · Amenorrea

Una paciente de 27 años de edad, con antecedente de parto hace 9 meses, dando lactancia materna parcial, consulta porque no ha iniciado sus menstruaciones aún. Está usando medroxiprogesterona inyectable intramuscular 150 mg cada 3 meses, como anticonceptivo. Su test de embarazo ha resultado negativo en más de una oportunidad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar prueba de progesterona
B) Solicitar TSH y prolactina
C) Solicitar niveles HCG en sangre venosa
D) Mantener el tratamiento
E) Solicitar ecografía transvaginal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es normal que esté en amenorrea si sigue dando lactancia y está con medroxiprogesterona (recordar que los anticonceptivos orales de elección en la lactancia son los progestágenos solos). Si bien su sensibilidad es algo más baja, por regla general, un test de embarazo negativo en orina, es suficiente para descartar el embarazo.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 5 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Una paciente de 48 años consulta por sangrado uterino, que no ha cesado desde su última menstruación, que inició hace dos semanas. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra útero de tamaño normal, con endometrio de 19 mm de grosor y sin alteraciones anexiales. Su PAP, realizado hace poco es normal y su test de embarazo en orina es negativo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Histerectomía
B) Ácido tranexámico endovenoso
C) Estrógenos inyectables
D) Anticonceptivos orales combinados
E) Biopsia de endometrio

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Biopsia de endometrio** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Histerectomía, Ácido tranexámico endovenoso) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 46 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Una paciente de 55 años, con menopausia a los 51 años y usuaria de estrógenos transdérmicos como terapia de reemplazo hormonal, consulta por sangrado genital de 5 días de evolución. Al examen Fsico, sus signos vitales son normales y la especuloscopía no muestra metrorragia ac8va ni lesiones del cuello uterino. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar histerectomía
B) Aumentar la dosis de estrógenos
C) Iniciar an2concep2vos orales
D) Solicitar biopsia de endometrio
E) Indicar ácido tranexámico vía oral

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Toda metrorragia postmenopáusica se debe estudiar. Existen dos opciones de estudio: 1. Ecografía transvaginal (el más usado) y 2. Directamente la biopsia endometrial (BEM), que habitualmente se hace por técnicas poco invasivas, como la Pipelle. En el caso de que se uGlice la ecografía, se ve el grosor del endometrio, si es menor a 5 mm, se asume que era atrofia vaginal y se observa. Si es de 5 mm o más, se biopsia. En caso de que esté con terapia de reemplazo hormonal (TRH), se biopsia desde 8 mm. Si se solicita una ecografía por otro motivo, en una paciente postmenopáusica sin metrorragia, también se biopsia desde los 11 mm. En resumen, las indicaciones de BEM en la postmenopausia: 1. Cualquier metrorragia (aceptable, sin EcoTV). 2. Metrorragia + EcoTV con EM > 4-5 mm (≥ 8 mm si TRH). 3. Asintomática + EcoTV con EM ≥ 11 mm

---

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 53 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Mujer de 22 años con ACO, metrorragia persistente 2 semanas y dolor hipogástrico hace 3 días, endometrio 15 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar β-HCG
B) Ecografía transvaginal urgente
C) Legrado uterino diagnóstico
D) Suspender ACO y observar
E) Solicitar hemograma y coagulación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar β-HCG** (opción **A**). Solicitar β-HCG. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 117 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Mujer 43 años con sangrado intermenstrual sin dolor, activa sexualmente con preservativo, cómo continuar el estudio:

A) BHCG y eco TV (este es el estudio inicial de todo SUA)
B) TSH y T4
C) FSH y LH
D) Biopsia Yo puse biopsia QUE PUSIERON?, no convencía BHCG. Sg yo la beta era solo porque estaba en edad fertil pero igual hay que hacerle una eco si o si.
E) Hemograma y VHS

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (BHCG y eco TV (este es el estudio inicial de todo SUA)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 82 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Una paciente de 31 años, usuaria de DIU desde hace 8 meses, consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de flujo menstrual muy abundante, asociado a escaso dolor abdominal. Se solicita hemograma, que muestra anemia con hemoglobina: 8,9 g/dl, VCM: 70 fl, HCM: 24 pg. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Iniciar anticonceptivos orales
B) Realizar biopsia de endometrio
C) Iniciar ácido tranexámico
D) Retirar el DIU
E) Realizar ecografía transvaginal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El DIU es causa de aumento del flujo menstrual y de dismenorrea. Se debe retirar y s epuede cambiar por un DIU medicado.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 85 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Una paciente de 15 años, consulta por hipermenorrea y menometrorragia, de Se solicita una ecografía transvaginal, que no muestra lesiones, ni alteraciones uterinas ni ováricas. El endometrio tiene 5 mm de grosor. Su hemograma muestra anemia leve, con glóbulos blancos: 7.000 por mm3 y plaquetas: 250.000 por mm3. La conducta más adecuada es:

A) Realizar biopsia de endometrio
B) Solicitar estudio de alteraciones de la hemostasia
C) Solicitar estudio de trombofilias
D) Solicitar resonancia magnética nuclear abdominopélvica
E) Solicitar endosonografía uterina (histerosonografía)

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las alteraciones de la hemostasia primaria, como la enfermedad de von Willebrand (EvW), pueden presentar hipermenorrea y es compatible con la edad de la paciente: de hecho, toda adolescente con aumento del flujo menstrual se debe estudiar al menos con un hemograma, plaquetas y tiempos de coagulación y luego se realizan las pruebas de agregación plaquetaria en busca de la EvW. Por la edad y por la delgado del endometrio es absolutamente improbable una hiperplasia endometrial o un cáncer de endometrio, como para elegir la biopsia o las otras opciones.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 180 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Mujer de 51 años consulta por metrorragia moderada de 10 días de evolución. Su última menstruación fue hace 6 meses. ¿Cuál es la causa mas probable de su hemorragia?

A) Atrofia vaginal
B) Hiperplasia endometrial
C) Cáncer de endometrio
D) Cáncer cervicouterino
E) Metrorragia disfuncional FIN DEL EXAMEN La

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por estar en el climaterio, es muy probable que sea disfuncional (es la causa más frecuente de metrorragia premenopausia). No aparecía atrofia endometrial como opción, sino atrofia vaginal, que está descartada.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 36 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Un paciente de 54 años, post menopáusica, sin uso de terapia de reemplazo hormonal, consulta por presentar metrorragia en dos oportunidades, sin otros síntomas. Se realiza especuloscopía que no muestra signos de sangramiento activo ni lesiones, el resto del examen físico resulta normal. El examen de elección en este caso es:

A) Realizar histeroscopía
B) Legrado biópsico endometrial
C) Ecografía abdominal
D) Colposcopía y biopsia
E) Ecografía transvaginal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El primer examen en la metrorragia postmenopáusica es la EcoTV. Luego se hace la BEM (biopsia de endometrio), a menos que el endometrio sea menor a 5 mm (o hasta 10 mm si usa TRH).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 171 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Una paciente de 58 años, con 18 meses de amenorrea, consulta por metrorragia de 2 días evolución. Su examen ginecológico demuestra escasa metrorragia, que proviene del OCE, sin otras alteraciones. Sus mamografía y PAP son normales y fueron realizados hace menos de un año. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 3 mm, sin masas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar colposcopía
B) Controlar con una ecografía en 1 mes
C) Realizar legrado
D) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
E) Realizar histeroscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una metrorragia postmenopáusica, con endometrio menor a 5 mm, por lo que probablemente es por atrofia endometrial, la que se suele observar.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 85 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Una paciente de 60 años, menopáusica desde los 50 años, consulta por metrorragia de 7 días de evolución. Al examen ginecológico se observa que la metrorragia proviene de la cavidad uterina. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Ecografía transvaginal
B) Histerosalpingografía
C) TAC de pelvis
D) Resonancia magnética de pelvis
E) Marcadores tumorales en sangre

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Ecografía transvaginal). La metrorragia postmenopáusica se estudia inicialmente con Ecografía TV.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 156 3.01.1.018 · Hemorragia genital anormal

Una mujer de 65 años, cuya menopausia fue a los 57 años, consulta por metrorragia de 20 días de evolución. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra dos miomas, uno submucoso de 16 mm y el otro subseroso de 44 mm, con endmetrio de 16 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuda?

A) Realizar miomectomía
B) Observar evolución
C) Realizar histerectomía
D) Iniciar terapia de remplazo hormonal
E) Realizar biopsia endometrial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los miomas NO producen la metrorragia. Tiene endometrio grueso. Se debe biopsiar para descartar una hiperplasia endometrial o un cáncer de endometrio.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 68 3.01.1.017 · Enfermedades de transmisió

Una paciente de 31 años multípara de uno, cursando un embarazo de 34 semanas, sin patología previa, acude a control, objetivándose lesiones vaginales, que se muestran a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea electiva
B) Aplicación local de podofilino
C) Iniciar aciclovir oral
D) Realizar tocaciones con ácido tricloroacético
E) Inducir el parto en este momento

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Condilomas acuminados genitales en embarazo: La imagen muestra condilomas acuminados, causados por el virus del papiloma humano (VPH), serotipos 6 y 11. A diferencia del herpes genital, los condilomas acuminados no contraindican el parto vaginal. El tratamiento de elección durante el embarazo es el ácido tricloroacético tópico. Otros tratamientos tópicos como el imiquimod y el podofilino, aunque eficaces para tratar los condilomas acuminados, están contraindicados durante el embarazo.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 46 3.01.1.017 · Enfermedades de transmisió

Paciente de 29 años, cursando embarazo de 38 semanas, consulta por aparición de vesículas dolorosas a nivel vulvar, sin otros síntomas. Al examen físico se apreian vesículas con base eritematosa a nivel vulvar. El examen de elección para el diagnóstico etiológio en este caso es:

A) Cultivo viral
B) PCR para virus herpes
C) Biopsia
D) Inmunoglobulina G para virus herpes
E) Tinción para virus herpes

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta mala. El diagnóstico es clínico y en la vida real no hay que pedir ningún examen y hacer cesárea. El gold standard siempre ha sido el cultivo viral, pero la PCR lo ha desplazado, por ser más rápida y más sensible. Yo marcaría PCR, pero el problema es que demora y hay que actuar de inmediato, por ser un embarazo y para decidir la vía de parto, lo único inmediato es la tinción de Tzank, aunque es un examen con mucho menor rendimiento. Sin embargo, no hay que rebuscarse y hay que responder ¿Qué examen es el mejor para el estudio del herpes genital?

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 69 3.01.1.017 · Enfermedades de transmisió

Una paciente de 25 años, embarazada, con 12 semanas contadas desde la FUR segura y confiable, se realiza exámenes, entre los que trae un VDRL, que resulta "no reactivo" y un MHA-TP, que resulta "reactivo". ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar penicilina benzatina de inmediato
B) Realizar VDRL mensual durante el resto del embarazo
C) Controlar con VDRL a las 30 semanas
D) Solicitar un FTA-ABS
E) Indicar doxiciclina vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las pruebas no treponémicas (VDRL, RPR) se negativizan tras el tratamiento exitoso. Las treponémicas (FTA-ABS, MHA-TP) permanecen positivas de por vida. VDRL no reactivo + MHA-TP reactivo = sífilis tratada en el pasado. Conducta: control prenatal habitual con VDRL a las 28-30 semanas.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 79 3.01.1.017 · Enfermedades de transmisió

Una paciente, con antecedente de varias parejas sexuales, consulta por disuria inicial y leucorrea. En la especuloscopía se observa cuello uterino con cambios inflamatorios y abundante leucorrea amarillenta, sin otras alteraciones en el examen ginecológico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vaginosis bacteriana
B) Proceso inflamatorio pélvico
C) Candidiasis urogenital
D) Tricomoniasis
E) Cervicitis gonocócica

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cervicitis gonocócica** (opción **E**). Es una cervicitis aguda clásica, cuyas causas más frecuentes son la gonorrea y la clamidia.. Esta clase aborda las generalidades de las ETS y cubre uretritis, herpes genital y condiloma acuminado. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 63 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una paciente de 30 años, nulípara, consulta por presentar reglas abundantes, asociado a astenia e hipersomnia. Al examen físico destacan mucosas pálidas, sin otros hallazgos. Se realiza hemograma donde destaca hemoglobina que resulta en 8mg/dL, y además se realiza ecografía transvaginal que muestra presencia de dos miomas intramurales. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Anticonceptivos orales
B) Agonistas de las gonadotrofinas
C) Histerectomía
D) Miomectomía
E) Observación

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Miomas sintomáticos en mujer sin hijos: miomectomía. Cierto es que los miomas intramurales suelen ser asintomáticos, pero en este caso se debe simplificar la pregunta a ¿cuál es el tratamiento de los miomas con hipermenorrea?

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 43 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una paciente de 56 años, usuaria de terapia de reemplazo hormonal y sin síntomas ginecológicos, se realiza una ecograFa abdominal durante el estudio de un cuadro cons8pación crónica. En dicho examen se detecta un mioma uterino subseroso de 32 × 35 mm, FIGO 6. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía
B) Suspender la terapia de reemplazo hormonal
C) Iniciar an2concep2vos orales
D) Realizar histerectomía
E) Realizar control ecográfico en 6 meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los miomas asintomáticos se observan, sin importar su clasificación. Por cultura general, la clasificación FIGO va del 1 al 8 y se refiere a la ubicación, en relación a la pared. Mientras más bajo, más hacia submucoso (hacia la cavidad uterina) y mientras más alto, más subseroso (hacia afuera). FIGO 4 es intramural puro y FIGO 6 es subseroso, con un componente intramural.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 162 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una paciente de 53 años acude a control ginecológico. Tuvo su menopausia a los 51 años y está en terapia de reemplazo hormonal, con estrógeno y progestágeno por vía oral, como tratamiento de los síntomas vasomotores del climaterio. Su examen ginecológico es normal, al igual que su mamograFa y PAP. Además, se solicita una ecograFa transvaginal, cuya imagen se presenta a con8nuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia endometrial
B) Controlar con ecogra:a en 6 meses
C) Suspender la terapia de reemplazo hormonal
D) Realizar resección de la lesión por laparoscopía
E) Instalar disposi2vo intrauterino medicado con levonorgestrel

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Controlar con ecogra:a en 6 meses** (opción **B**). Tiene un mioma asintomático, por lo que se debe observar evolución. Fuente imagen: hxps://we.riseup.net/assets/230674/.... Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 51 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una paciente de 35 años, nulípara, consulta por una historia de un año de evolución de flujo menstrual abundante y, en ocasiones, flujo intermenstrual escaso. Usa preservativo como método anticonceptivo. Su examen físico no muestra alteraciones. Trae hemograma con hemoglobina: 10,5 mg/dl, hematocrito 31%, VCM: 70 fl, blancos: 6.000 por mm3 y plaquetas: 250.000 por mm3. Se realiza ecografía transvaginal, que demuestra presencia de mioma submucoso de 2 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Histerectomía total
B) Resonancia magnética nuclear de pelvis
C) Observar evolución
D) Miomectomía histeroscópica
E) Resección del mioma por laparoscopía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de Miomas Uterinos: Los miomas uterinos se diagnostican con ecografía. El manejo depende de los síntomas y la paridad. La miomatosis asintomática solo se observa. La miomatosis sintomática se trata con cirugía. En mujeres con deseos de paridad, se prefiere la cirugía conservadora con miomectomía histeroscópica. En los miomas submucosos es de elección la miomectomía histeroscópica. En mujeres con paridad cumplida, con miomas intramurales o subserosos sintomáticos se puede realizar una histerectomía total. Sin embargo, las recomendaciones internacionales priorizan el manejo médico (Ej. ACO o agonistas de la GnRH) antes de la cirugía, debido a los riesgos de la histerectomía, pero, en la práctica en Chile se manejan con cirugía cuando son sintomáticos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 154 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una paciente de 50 años consulta por amenorrea de 8 meses de evolución. Se realiza ecografía transvaginal que muestra múltiples imágenes nodulares, hipoecogénicas intramurales y subserosas de hasta 3 cm. La indicación más adecuada es:

A) Histerectomía
B) Ecografía en 6 meses
C) Terapia de reemplazo hormonal
D) Análogos de la GnRH
E) Biopsia por histeroscopía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene miomas asintomáticos (la amenorrea no es síntoma de miomas), por lo que se observan. Además, por estar en amenorrea a los 50 años, probablemente esté menopáusica y, con ello, los miomas tienden a involucionar (aunque da igual en realidad).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 151 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una paciente de 43 años, multípara de 4, consulta por que en el último tiempo se ha sentido más cansada de lo normal y además presenta disnea de grandes esfuerzos. Refiere también como antecedente, que sus reglas son abundantes. En su examen ginecológico, destaca útero en ateversoflexión, irregular y anexos sin alteraciones palpables. En sus exámenes de laboratorio destaca un hemograma, con Hb: 8 g/dl, Hcto: 23%, blancos: 6.500 por mm3 y plaquetas: 260.000 por mm3, que en el frotis muestra hipocromía y microcitosis. Se solicita una ecografía transvaginal, que muestra múltiples miomas intramurales de hasta 5 cm de diámetro, más un mioma submucoso de 4 cm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar histeroscopía
B) Realizar histerectomía total
C) Administrar análogos de la GnRH
D) Iniciar anticonceptivos orales
E) Antifibrinolíticos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar histerectomía total** (opción **B**). La miomatosis sintomática, se opera. Si ya tiene paridad cumplida, se prefiere la HT.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 79 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una paciente de 35 años, multípara de dos, se realiza una cesárea por presentación podálica. Luego de la extracción del recién nacido y del legrado uterino, se observan múltiples miomas uterinos subserosos de variados tamaños. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar miomectomía múltiple
B) Realizar histerectomía subtotal
C) Realizar miomectomía selectiva de los tumores mayores a 5 cm
D) Realizar histerectomía obstétrica
E) Realizar el cierre habitual de la cesárea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los miomas asintomáticos (en este caso simple hallazgo en la cesárea) no requieren tratamiento alguno.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 166 3.01.1.021 · Mioma uterino

Una mujer de 53 años, con antecedente de reglas irregulares, está en amenorrea desde hace 9 meses. Su examen ginecológico es normal y cuenta con mamografía y Papanicolau recientes, sin alteraciones. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra endometrio fino y miometrio con múltiples nódulos hipoecogénicos subserosos y transmurales de entre 2 y 4 cm de diámetro. La indicación más adecuada es:

A) Histerectomía total
B) Tumorectomía
C) Análogos de GnRH
D) Anticonceptivos orales
E) Observar evolución

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un climaterio y probable menopausia (cuando cumpla 12 meses de amenorrea se hará el diagnóstico de menopausia). La presencia de miomas asintomáticos es un hallazgo ecográfico sin importancia.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 134 3.01.5.010 · Parto normal

Embarazada de 37 semanas, primigesta, presenta contracciones uterinas desde hace dos horas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se constata dinámica uterina de dos contracciones en 10 minutos y auscultación de latidos cardiofetales normal. Se realiza tacto vaginal donde se aprecia borramiento del 100% y tres centímetros de dilatación. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Realizar cesárea
B) Administrar tocolíticos
C) Indicar antibióticos y corticoides
D) Conducir trabajo de parto
E) Solicitar perfil biofísico

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Está en trabajo de parto, pasando de la fase latente a la activa. NO tiene ningún criterio de gravedad o que contraindique el parto vaginal.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 149 3.01.1.020 · Infertilidad conyugal

Una pareja joven consulta por infertilidad, refieren que llevan 15 meses intentando tener hijos pero no han tenido resultado, ambos no tienen hijos anteriormente. El hombre trae consigo espermiograma que se realizó hace dos semanas que está normal. Ella nunca ha utilizado anticonceptivos orales y refiere ciclos menstruales normales, su examen físico resulta normal. El examen de elección para continuar el estudio de infertilidad en este caso es:

A) Repetir espermiograma
B) Test post coital
C) Laparoscopía
D) Histeroscopía
E) Histerosalpingografía

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
De elección es el seguimiento folicular, que no está dentro de las alternativas. El test postcoital requiere de un seguimiento folicular y se le pide que tengan relaciones el día previo a la ovulación (se sabe ese día por el Seguimiento folicular ecográfico), de modo de evaluar el factro cervical además. Los demás exámenes son de segunda o tercera línea

---

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 109 3.01.1.020 · Infertilidad conyugal

Una paciente de 30 años, con un hijo de 5 años con otra pareja, consulta por infertilidad de 3 años con su nueva pareja. Ella cuenta con estudio hormonal normal y él tiene un espermiograma sin alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Realizar cariograma
B) Repetir el espermiograma
C) Solicitar fragmentación de ADN espermático
D) Realizar laparoscopía diagnóstica
E) Realizar histerosalpingografía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El estudio de la infertilidad siempre es de la pareja y no importa si tienen hijos de antes. El hombre solo se estudia con espermiograma. La mujer se estudia con exámenes por etapas: la primera línea es el seguimiento folicular con ecografías seriadas y exámenes hormonales; de segunda línea se pide la histerosalpingografía (busca alteraciones tubepritoneales); de tercera línea se hace la laparoscopía exploradora, en busca de endometriosis.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 108 · 3.01.1.020 · Infertilidad conyugal

Una paciente de 28 años acude a la clínica de fertilidad. Presenta reglas irregulares, que ocurren cada 2 a 3 meses. Al examen físico se observa obesa y tiene hirsutismo y acné, sin alteraciones en el examen ginecológico. Se solicita prueba de HOMA, que resulta 2,1 (VN: < 2,6) y se realiza una ecografía transvaginal que muestra útero normal, con ovarios poliquísticos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para lograr la fertilidad en esta paciente?

A) Espironolactona
B) Análogos de la GnRH
C) Citrato de clomifeno
D) Metformina
E) Progesterona

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene infertilidad por anovulación, secundaria al SOP (cumple criterio ecográfico y menstrual). Se induce la ovulación con clomifeno. La metformina podría ser útil, pero solo en las pacientes con resistencia a la insulina (no es el caso, por tener HOMA normal).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 162 · 3.01.1.020 · Infertilidad conyugal

Una paciente de 32 años presenta reglas irregulares, cada 2 a 3 meses, asociada a hirsutismo y acné. Consulta porque ha tenido problemas para embarazarse ¿Cuál es el mejor fármaco para de tratar la infertilidad en esta paciente?

A) Espironolactona
B) Análogos de la GnRH
C) Citrato de clomifeno
D) Metformina
E) Progesterona

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Citrato de clomifeno** (opción **C**). La infertilidad del SOP es por anovulación, que se trata con inductores, como el clomifeno.. Tratamiento según Causa De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 78 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 8 meses, asociadas a bochornos frecuentes, con calor, enrojecimiento de la cara, sudoración nocturna y dificultades para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada para el manejo de los síntomas de esta paciente?

A) Fitoestrógenos
B) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D) Estrógenos solos continuos
E) Progestágenos solos continuos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene síntomas climatéricos, que se tratan con terapia de reemplazo hormonal. La regla general es que se usan estrógenos más progestágenos, salvo en las pacientes histerectomizadas, en que se usa estrógeno solo. En este caso tiene útero, ya que tiene reglas irregulares. En los casos en que la TRH está contraindicada (ej. cáncer de mama) se usan los antidepresivos, ya sea IRS o venlafaxina. En la práctica, suele indicarse de tipo continua, ya que no sirve mayormente la TRH cíclica (aunque hay quienes postulan que sirve en el inicio de los síntomas climatérico, como una forma de ciclar a la paciente con reglas irregulares; sin embargo, en la práctica casi no existen fármacos de ese tipo disponibles en el medio chileno, salvo que use ACOs como TRH).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 139 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

¿Qué antecedente es indicación del uso de estrógenos orales solos, en la terapia de reemplazo hormonal?

A) Antecedente de cáncer de mama
B) Antecedente de dislipidemia
C) Antecedente de histerectomía total
D) Osteoporosis
E) Edad mayor a 70 años

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El uso de progestágeno en la TRH está solo indicado para evitar el cáncer de endo- metrio. Si hay histerectomía, se hace innecesario dar progestágeno y se dan estrógenos solos.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 43 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Mujer de 56 años postmenopáusica con sequedad vaginal severa, dispareunia y urgencia urinaria. Sin tratamiento actual. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

A) Estrógenos tópicos vaginales
B) Estrógenos orales sistémicos
C) Lubricantes vaginales sin hormonas
D) Ospemifeno oral
E) Testosterona tópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Síndrome genitourinario de la menopausia (sequedad vaginal + dispareunia + síntomas urinarios): primera línea = estrógenos tópicos vaginales (crema, óvulos o anillo). Acción local, mínima absorción sistémica, pueden usarse incluso en pacientes con CA mama en muchos contextos.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 47 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Mujer en menopausia con sequedad vaginal y dispareunia, atrofia de la mucosa vaginal. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Lubricante vaginal sin hormonas
B) Terapia hormonal sistémica
C) Promestrieno tópico vaginal
D) Estriol oral
E) Tibolona oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Promestrieno tópico vaginal** (opción **C**). Promestrieno tópico vaginal. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 178 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una mujer de 49 años obesa consulta por síntomas vasomotores consistentes en calor y enrojecimiento de pecho y cara, que ocurren con frecuencia, especialmente en la noche. Refiere que sus menstruaciones son cada vez más infrecuentes, cada 2 a 3 meses. ¿Qué tratamiento es el más adecuado para el manejo de sus síntomas?

A) Estrógeno más progesterona vía oral
B) Estrógeno más progesterona transdérmicos
C) Paroxe2na
D) An2concep2vos orales combinados
E) Estrógeno tópico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los síntomas vasomotores son indicación de terapia de reemplazo hormonal (TRH). Por tener útero se indica una asociación de estrógeno y progestina (en histerectomizadas se usa estrógeno solo). La vía de administración suele ser oral, aunque algunos prefieren la vía transdérmica se recomienda en pacientes obesas y con hipertrigliceridemia. Aunque no existe buena evidencia que respalde estas recomendaciones, la dislipidemia suele ser aceptada por la mayoría de las fuentes como indicación de la vía transdérmica. En cambio, la obesidad es algo más discuGble. De todos modos, de la redacción de la pregunta, lo más probable es que quien redactó la pregunta haya querido preguntar esa excepción. Tema aparte, los estrógenos tópicos se usan en los síntomas limitados a la zona urogenital (ej. atrofia vaginal con dispareunia), sin síntomas vasomotores, cuando ha fallado el uso de lubricante genital.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 42 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Mujer de 52 años con menopausia hace 2 años y sequedad vaginal severa. Inicia estrógenos tópicos vaginales. ¿Con qué frecuencia se deben aplicar en la fase de mantenimiento?

A) Una vez al día
B) Dos veces al día
C) Dos o tres veces por semana
D) Una vez por semana
E) Solo durante el período sintomático

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Estrógenos tópicos vaginales: fase inicial diaria por 2 semanas, luego mantenimiento 2-3 veces por semana. Dos veces al día en mantenimiento es dosis excesiva innecesaria.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 88 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una mujer de 52 años presenta reglas irregulares, desde hace 6 meses, asociada a bochornos frecuentes, con calor y enrojecimiento de la cara, que le molestan para dormir. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Fitoestrógenos
B) Terapia de reemplazo hormonal combinada continua
C) Terapia de reemplazo hormonal combinada cíclica
D) Estrógenos solos continuos
E) Progestágenos solos continuos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La TRH comúnmente indicada es la combinada (estrógeno más progestágeno) continua. Si hubiese sido histerectomizada, se indican estrógenos solos.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 47 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una paciente de 68 años, consulta por disuria y dispareunia de 5 meses de evolución, que ha ido en aumento. Cuenta con múltiples exámenes de orina y urocultivos, que han resultado negativos. En su examen físico, se constata mucosa vaginal pálida y seca, flujo patológico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Promestireno tópico vaginal
B) 17 beta estradiol por vía oral
C) Tibolona oral
D) Acetato de medroxiprogesterona por vía oral
E) Estradiol más dienogest por vía oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **17 beta estradiol por vía oral** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 61 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Mujer de no se q edad 40-50? Menopáusica con clínica de 5 años de evolución con dispareunia y sequedad vaginal severa, sin ningún otro síntoma. con antecedente de ca de mama en tto con tamoxifeno. preguntan conducta inicial

A) Lubricante e hidratante vaginal
B) Estrógenos vaginales
C) Suspender tamoxifeno
D) Observación clínica
E) Derivar a urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Lubricante e hidratante vaginal** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 4 · 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una mujer de 54 años, menopáusica hace 2 años, con antecedente de enfermedad coronaria, consulta por sudoración y sensación calor en el pecho y rostro, que ocurre en episodios frecuentes y molestos, mayores en la noche. ¿Cuál es la terapia de elección?

A) Estradiol tópico intravaginal
B) Escitalopram oral
C) Tibolona oral
D) Terapia hormonal combinada de 17 beta estradiol más drospirenona por vía oral
E) Estradiol y progesterona combinados por vía transdérmica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Terapia hormonal combinada de 17 beta estradiol más drospirenona por vía oral). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 87 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una paciente de 35 años, con antecedente de una histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino, hace dos años, consulta por bochornos frecuentes, asociado a sequedad genital y dispareunia, más insomnio, secundaria a los bochornos. En su examen físico tiene IMC: 28. Se solicitan exámenes, en los que destaca colesterol total: 221 mg/dl, colesterol HDL: 32 mg/dl y triglicéridos: 456 mg/dl. La conducta más adecuada es:

A) Estrógeno más progestágeno oral
B) Estrógeno solo vía oral
C) Estrógeno en parches
D) Venlafaxina oral
E) Progestágenos tópicos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un hipogonadismo, secundario a la histerectomía radical, en que se extirpan los ovarios, por lo que requiere TRH, para manejar sus síntomas vasomotores y genitales (atrofia). Por estar histerectomizada solo se dejan estrógenos, sin progestágenos (sí hay que dejarlos si hay útero). Por tener dislipidemia, debe evitarse la vía oral y sirven más los parches. La venlafaxina se usa como tratamiento de los síntomas vasomotores cuando están contraindicados los estrógenos, pero no sirve para la atrofia genital.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 9 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Postmenopáusica con antecedente de IAM y bochornos: a. iniciar Escitalopram

B) Resto opciones tenian estradiol
B) Ninguna de las anteriores es correcta
C) Todas las anteriores son correctas
D) No se dispone de información suficiente
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Resto opciones tenian estradiol, Ninguna de las anteriores es correcta) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 75 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una paciente de 51 años, obesa, con antecedente de menopausia a los 48 años, consulta por síntomas vasomotores intensos caracterizados por enrojecimiento y calor de la cara y pecho, mayores en la noche y que son muy molestos. Hace un año se realizó una histerectomía total, debido a diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de sus síntomas?

A) Estradiol más dienogest por vía oral
B) Estriol por vía vaginal
C) Estradiol gel, por vía transdérmica
D) Anticonceptivos orales combinados
E) Venlafaxina vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Terapia de Reemplazo Hormonal: Los síntomas vasomotores de la menopausia se tratan con terapia de reemplazo hormonal (TRH), a menos que esté contraindicada. Un antecedente de hiperplasia endometrial atípica no contraindica la TRH si ya fue tratada, pero sí lo haría si estuviera activa. La histerectomía implica que la TRH se realice solo con estrógeno, a diferencia de las pacientes con útero que reciben estrógeno y progestágeno. La vía de administración suele ser oral, pero se prefiere la vía transdérmica en casos de dislipidemia o factores de riesgo cardiovascular importantes, aunque la evidencia es limitada. En este caso, la paciente era obesa, por lo que la vía transdérmica es aceptable. El estriol u otros estrógenos tópicos vaginales se usan solo para síntomas genitales sin síntomas vasomotores, si no responden a lubricación.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 19 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Mujer con síntomas menopáusicos, con FRCV, histerectomizada, cuál es la mejor opción de manejo: a. Estradiol tópico

B) Estradiol
B) Amoxicilina
C) Ibuprofeno
D) Paracetamol
E) Omeprazol

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Estradiol** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Ibuprofeno, Paracetamol) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 46 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Mujer en menopausia con bochornos y sudoración, antecedente de IAM a los 49 años. ¿Cuál es la terapia más adecuada?

A) Terapia hormonal con estrógenos solos
B) Terapia hormonal combinada (estrógeno + progestina)
C) Tibolona oral
D) Clonidina transdérmica
E) Escitalopram 10 mg/día

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Escitalopram 10 mg/día). Escitalopram 10 mg/día. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Terapia hormonal con estrógenos solos, Terapia hormonal combinada (estrógeno + proge) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 148 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una paciente de 42 años se realiza un histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino. Evoluciona con bochornos, cefalea y dispareunia profunda, por resequedad vaginal. Al examen físico tiene sobrepeso y presi´pon arterial normal. Además trae exámenes en los que destaca Colesterol total: 204 mg/dl, Colesterol HDL: 54 mg/dl, Triglicéridos: 405 mg/dl. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

A) Estrógenos más progestágenos orales
B) Estrógenos orales
C) Estrógenos en parches
D) Progestágenos endovaginales
E) Sertralina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por estar histerectomizada, debe recibir estrógeno solo y por ser dislipidémica, debe ser por vía transdérmica. Recordar que lo habitual es dar estrógenos más progestágenos, para evitar el riesgo de cáncer de endometrio, pero con la histerectomía, ya no existe el riesgo de dicho cáncer y bastan los estrógenos.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 159 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una paciente de 48 años, consulta por episodios de calor y enrojecimiento de la cara y la zona superior del tórax, que duran algunos minutos y ceden espontáneamente, no ha presentado menstruación en los últimos doce meses. Su examen físico es normal. Refiere antecedente de hermana con cáncer de mama. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría como terapia de reemplazo hormonal en esta paciente?

A) Tibolona
B) Estrógenos y progestágenos orales
C) Estrógenos transdérmicos
D) Tamoxifeno
E) Venlafaxina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por el antecedente familiar de cáncer evitar los estrógenos, pero es fuertemente discutible, ya que las recomendaciones solo plantean como contraindicación al antecedente personal de cáncer de mama y no al antecedente familiar, sin embargo este es uno de los casos en que se da la tibolona, sabiendo que no hay mucha evidencia que lo respalde. La venlafaxina igual se usa, aunque no sirve mucho. Tibolona es la respuesta más correcta.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 180 3.01.1.027 · Síndrome climatérico y men

Una mujer de 35 años, con antecedente de parto hace 3 meses, actualmente dando lactancia materna, consulta por dispareunia y prurito postcoital de algunas semanas de evolución. En su especuloscopía se observan paredes vaginales con mucosa pálida y seca

A) Realizar cultivo para Candida
B) Realizar microscopía en búsqueda de Trichomonas vaginalis
C) Iniciar anticonceptivos combinados orales
D) Realizar búsqueda de “clue cells”
E) Indicar lubricante íntimo genital 0 A Sin duda es el mejor curso, además de ser el más completo y actualizado.

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una atrofia vaginal, por hipoestrogenismo fisiológico. Se trata de primera línea, con lubricación genital. Guillermo Guevara | Scholarship Theme por Mystery Themes.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 161 3.01.1.029 · Patología benigna de mama

Una paciente de 24 años se autopalpa un nódulo mamario de 2 cm, indolora, que no está adherida a la piel ni a planos profundos. Se solicita una ecografía mamaria que muestra una lesión bien delimitada, de 25 mm de diámetro, homogénea, con una fina pared que la rodea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste mamario
B) Fibroadenoma
C) Cáncer de mama
D) Papiloma mamario
E) Tumor filoides

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Fibroadenoma** (opción **B**). Es un fibroadenoma clásico (joven con nódulo liso y móvil).. La patología benigna de mama incluye el fibroadenoma, el quiste simple, la mastopatía fibroquística y la mastalgia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 169 3.01.1.029 · Patología benigna de mama

Una paciente de 43 años, sin antecedentes, consulta por aparición de nódulo mamario, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se palpa nódulo pequeño, no adherido, de consistencia gomosa, sin presencia de adenopatías axilares. Se realiza mamografía inicialmente que es informada como BIRADS 0, por lo que se solicita ecografía mamaria que muestra un nódulo sólido de bordes regulares, con paredes lisas de dos milímetros. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Control con mamografía anual
B) Realizar biopsia estereotáxica
C) Realizar tumorectomía con biopsia rápida
D) Indicar estrógenos orales y controlar al año con nueva ecografía
E) Control con ecografía en seis meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un fibroadenoma. Se observa, pero se recomienda pedir una Eco en 6 meses porque hay un Cáncer de mama raro, que puede verse igual. Igual es una pregunta muy difícil. También sería correcto la mamografía en un año. Sí estoy seguro que los fibroadenomas se deben controlar al menor por un año con Eco, para asegurarse que no crezcan, como el cáncer raro mencionado.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 12 3.01.1.029 · Patología benigna de mama

Una mujer de 23 años consulta porque se palpó un nódulo mamario en la mama derecha. Al examen físico tiene un nódulo de 5 cm, que se palpa liso y móvil. Se solicita ecografía mamaria, que muestra un nódulo de aspecto sólido, bien delimitado y encapsulado, de aspecto homogéneo, clasificación US-BIRADS2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia estereotáxica
B) Control con mamografía en un año
C) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas
D) Controlar con nueva ecografía mamaria en 6 meses
E) Realizar remoción quirúrgica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Control con mamografía en un año** (opción **B**). El tratamiento de la mastopatía fibroquística es educación de que no es cáncer ni se transforma en cáncer, se resuelve con la menopausia, y AINEs como ácido mefenámico para el dolor. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 57 · 3.01.1.029 · Patología benigna de mama

Una mujer de 43 años se realiza una mamografía de control, que muestra la presencia de un nódulo mamario, que es catalogado como Bi-Rads 3. Se solicita ecografía mamaria, que no muestra lesiones. Su examen mamario no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar una mamografía en 6 meses
B) Solicitar resonancia magnética nuclear de mama
C) Solicitar estudio de genes BRCA 1 y BRCA 2
D) Biopsia por punción con aguja fina
E) Biopsia estereotáxica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Biopsia por punción con aguja fina** (opción **D**). El tratamiento de la mastopatía fibroquística es educación de que no es cáncer ni se transforma en cáncer, se resuelve con la menopausia, y AINEs como ácido mefenámico para el dolor. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 76 · 3.01.1.029 · Patología benigna de mama

Mamografía BIRADS 0, se realiza ECO y resulta BIRADS 2, conducta:

A) Control 6 meses con eco (no describían la lesión pero asumo que se trataba de un fibroadenoma mamario y esta sería la conducta)
B) Control 6 meses con mamografía (BIRADS 2 se controlan en 1 año con mamografia así que esta no podía ser)
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Control 6 meses con eco (no describían la lesión pero asumo que se trataba de un fibroadenoma mamario y esta sería la conducta)** (opción **A**). El tratamiento de la mastopatía fibroquística es educación de que no es cáncer ni se transforma en cáncer, se resuelve con la menopausia, y AINEs como ácido mefenámico para el dolor. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 121 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Mujer de 28 años con dispareunia (dolor a la penetración), flujo vaginal gris homogéneo con mal olor (peor post coito) y pH vaginal 5.5. Test de aminas positivo (KOH). ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

A) Vaginosis bacteriana: metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días
B) Candidiasis vaginal: fluconazol oral 150 mg dosis única
C) Tricomoniasis: metronidazol 2 g dosis única
D) Herpes genital: aciclovir
E) Cervicitis por clamidia: azitromicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Criterios de Amsel: flujo gris homogéneo + pH >4.5 + test de aminas + (+) células clave = vaginosis bacteriana. Tratamiento: metronidazol oral 500 mg c/12h x 7 días o clindamicina vaginal.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 32 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente de 31 años de edad refiere mal olor genital, asociado a flujo, que empeora cuando tiene relaciones sexuales. Es usuaria de dispositivo intrauterino de cobre, desde hace 4 años. No tiene PAP vigente, por lo que se solicita un nuevo PAP, que resulta normal. En la especuloscopía se observa leucorrea de color gris, sin lesiones cervicales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el DIU bajo cobertura antibiótica
B) Solicitar cultivo de secreción vaginal
C) Indicar clindamicina tópica en óvulos
D) Indicar clotrimazol tópico en óvulos
E) Indicar fluconazol oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Vaginosis Bacteriana: El diagnóstico probable es vaginosis bacteriana, que se trata con metronidazol oral, siendo una alternativa la clindamicina tópica. No se debe confundir con la enfermedad inflamatoria pélvica que se presenta con dolor, flujo purulento y fiebre. El tratamiento para esta última condición consiste en antibióticos (orales o intravenosos según la gravedad) y la extracción del DIU si no hay respuesta en 48 horas.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 116 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente de 27 años, usuaria de dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, consulta por flujo genital de mal olor que empeora después de tener relaciones sexuales. Al examen físico se observa cuello uterino normal y secreción vaginal de color gris. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el dispositivo intrauterino bajo cobertura antibiótica
B) Indicar fluconazol vía oral
C) Iniciar doxiciclina vía oral
D) Realizar VDRL a la paciente y a su pareja.
E) Indicar metronidazol por vía oral

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Vaginosis Bacteriana y DIU: La paciente presenta un cuadro clínico compatible con vaginosis bacteriana, la cual se trata con metronidazol vía oral o clindamicina tópica. A diferencia del proceso inflamatorio pélvico que no responde al tratamiento antibiótico después de 48 horas, en la vaginosis bacteriana no es necesario retirar el DIU.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 34 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Embarazada de 20 semanas con urocultivo positivo para E. coli sensible. Sin alergias. ¿Cuál es el antibiótico de elección para la infección urinaria en el embarazo?

A) Cefalexina oral por 7 días
B) Amoxicilina oral
C) Cotrimoxazol (contraindicado en tercer trimestre)
D) Ciprofloxacino (contraindicado en embarazo)
E) Nitrofurantoína (evitar en tercer trimestre)

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

ITU en embarazo: cefalexina oral 500 mg c/6-8h por 7 días es de primera línea en Chile. Ciprofloxacino: contraindicado (artropatía fetal). Cotrimoxazol: contraindicado en tercer trimestre (kernicterus). Nitrofurantoína: evitar en tercer trimestre. Cefalexina: segura en todos los trimestres.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 178 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente de 26 años, sin antecedentes, consulta por secreción vaginal asociada a prurito. Al examen físico se aprecia liquenificación y signos de grataje a nivel vulvar, a la especuloscopía se aprecia leucorrea blanquecina. El fármaco de elección para el manejo en este caso es:

A) Metronidazol
B) Fluconazol
C) Miconazol
D) Doxiciclina
E) Ceftriaxona

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Fluconazol** (opción **B**). Es una candidiasis genital. De elección se trata con fluconazol 150 mg v.o. por 1 vez.. Comparación de las 3 Causas Principales De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 136 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Pregunta 136 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente cursando un embarazo de 7 semanas de evolución, presenta prurito vaginal desde hace 7 días, con leucorrea de aspecto grumoso. Se realiza un cultivo vaginal, que muestra desarrollo de Streptococcus betahemolítico grupo B y Candida albicans. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Clotrimazol tópico
B) Ampicilina oral
C) Azitromicina oral
D) Fluconazol oral
E) Clindamicina tópica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una candidiasis y por estar embarazada, se prefiere el tratamiento tópico. De lo contrario, también habría sido correcto el fluconazol.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 176 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente de 33 años, con antecedente de molestias urinarias, caracterizadas por disuria dolorosa, por lo que es diagnosticada de infección urinaria y tratada con ciprofloxacino oral, con buena respuesta clínica. Sin embargo, algunos días después reaparece el ardor al orinar y presenta prurito genital. Al examen físico se aprecia eritema de la mucosa vulvar, sin leucorrea y se observan erosiones lineales a nivel de la horquilla. El tratamiento más adecuado es:

A) Cotrimoxazol
B) Fluconazol
C) Metronidazol
D) Doxicilina
E) Aciclovir

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una infección por Candida albicans, secundaria al uso de antibióticos, por tanto, se trata co fluconazol. Orientan a ello el prurito vaginal, la disuria y el compromiso de la horquilla. Eso sí, la ausencia de leucorrea inducía a la confusión, ya que habitualmente se pregunta con la infección más interna, con la leucorrea blanca grumosa clásica.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 176 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente cursa un embarazo de 24 semanas y es diagnosticada de infección urinaria baja, por Escherichia coli sensible, que se resuelve adecuadamente, luego de tratamiento antibiótico por 7 días. Tiene antecedente de una bacteriuria asintomática, tratada a las 16 semanas de embarazo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar urocultivo semanal
B) Solicitar pielografía de eliminación
C) Indicar aumento del consumo de agua
D) Indicar nitrofurantoína a permanencia
E) Indicar profilaxis, con jugo de cranberry

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La indicación de profilaxis antibiótica (con cefradina o nitrofurantoína) son 2 o más infecciones tratadas (independiente de si son bacteriurias asintomáticas, ITU baja, pielonefritis o mezclas de ellos).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 147 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una mujer de 23 años, cursando un embarazo de 20 semanas, sin complicaciones, se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli multisensible, 60.000 UFC por ml. La conducta más adecuada es:

A) Repetir el urocultivo en 2 semanas
B) Iniciar cefradina vo
C) Iniciar ciprofloxacino vo
D) Solicitar ecografía
E) Iniciar ceftriaxona ev

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El UCT está negativo, ya que para ser positivo requiere más de 100.000 UFC por ml. Por tanto, la única opción correcta es la A.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 137 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente de 23 años, cursando un embarazo de 7 semanas, presenta un cuadro de disuria y polaquiuria, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible, con más de 100.000 UFC. El tratamiento más adecuado es:

A) Cotrimoxazol
B) Flucloxacilina
C) Nitrofurantoína
D) Levofloxacino
E) Ciprofloxacino

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El tratamiento de elección de la ITU en el embarazo son las cefalosporinas de primera generación. Pero no aparecía en las alternativas, por lo que la única aceptable era la nitrofurantoína, ya que las demás opciones o no cubren la ITU o están contraindicados en el embarazo.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 30 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Un paciente de 24 años, cursando un embarazo de 8 semanas, consulta por leuco- rrea y molestias genitales. Se realiza una especuloscopía, que se muestra a continua- ción: INSERTAR FOTO El tratamiento de elección es:

A) Metronidazol oral
B) Clotrimazol tópico
C) Tinidazol oral
D) Fluconazol oral
E) Azitromicina oral

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una candidiasis y por estar embarazada, se debe evitar el fluconazol oral y pre- ferir el tratamiento tópico.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 117 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente de 30 años consulta por molestias genitales, consistentes en leuco- rrea y prurito. Al examen ginecológico, destaca especuloscopía con leucorrea abundan- te, amarilla y espumosa. ¿Cuál es el examen de elección para realizar el diagnóstico etiológico?

A) Prueba de aminas vaginales (test de KOH)
B) Cultivo para cándida albicans
C) Examen de determinación de "células clave" (clue cells)
D) Frotis fresco de la secreción vaginal
E) PCR para Chlamydia trachomatis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Frotis fresco de la secreción vaginal** (opción **D**). Es una tricomoniasis y el frotis permite ver a las tricomonas.. :::note El metronidazol en monodosis de 2 g es la elección para tricomoniasis, NO para vaginosis. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 172 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente consulta por leucorrea, asociada a prurito vaginal importante. Al examen físico se observa vulvovaginitis, con leucorrea de mal olor, con pH de 5,8 y test de KOH positivo. ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Metronidazol a la paciente y a su pareja
B) Tinidazol
C) Clindamicina
D) Fluconazol a la paciente y a su pareja
E) Azitromicina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una vaginosis (KOH positivo y leucorrea con pH mayor a 4,5 y mal olor), pero también una tricomoniasis (vulvovaginitis y leucorrea de mal olor). El prurito es de cándida y de tricomona. Tanto vaginosis, como tricomoniasis se tratan con metronidazol. Además la tricomoniasis obliga a tratar a la pareja y a descartar otras ETS.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 16 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente de 35 años, puérpera de 3 meses, consulta por disuria, dispareunia y molestias genitales. Al examen físico, tiene la mucosa genital seca y pálida, sin leucorrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tricomoniasis
B) Candidiasis
C) Vaginosis
D) Atrofia genital
E) Infección por clamidia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto la clínica como el antecedente de estar en lactancia orientan a atrofia. Otras causas de atrofia vaginal son embarazo y menopausia. No confundir con la atrofia endometrial, que es causa de metrorragia y que se ve en las mismas causas, más los ACO y TRH que contienen progestágenos, pero que no producen atrofia vaginal, por tener también estrógenos.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 161 · 3.01.1.019 · Infecciones genitourinaria

Una paciente, con antecedente de mortinato por infección por estreptococo betahemolítico grupo B, cursa un nuevo embarazo de 35 semanas, que no ha presentado complicaciones y se ha controlado adecuadamente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar penicilina endovenosa al recién nacido
B) Administrar ampicilina endovenosa a la mujer durante el trabajo de parto
C) Solicitar cultivo perianal y decidir conducta
D) Dar antibióticos profilácticos en este momento
E) Realizar cesárea electiva al término

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una paciente de alto riesgo, por lo que se debe dar profilaxis en el parto y no se solicita el cultivo. En las de bajo riesgo, sí se solicita el cultivo para decidir.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 47 · 3.01.1.032 · Incontinencia urinaria

Una paciente de 57 años, multípara de 5, presenta incontinencia de esfuerzos moderados. Su examen físico muestra genitales normales, sin prolapso. Tiene sedimento de orina normal y urocultivo negativo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

A) Oxibutinina
B) Suspensión uretral
C) Terapia de remplazo hormonal
D) Kinesioterapia pélvica
E) Doxasozina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una incontinencia de orina de esfuerzos. El orden a tratar es: descartar ITU, luego kinesioterapia pélvica (ejercicios de Koegel) y finalmente la cirugía (suspensión uretral con TOT o TVT).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 91 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente de 35 años, multípara de 1, se realiza PAP de control, que es informado como presencia de atipias escamosas de significado incierto (ASC-US). Su especuloscopía es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar colposcopía y biopsia cervical
B) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para virus papiloma humano
C) Realizar diatermocoagulación cervical
D) Realizar histerectomía
E) Realizar biopsia de endometrio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Manejo de ASCUS (Células Escamosas Atípicas de Significado Incierto): Vale la pena recordar que las indicaciones más importantes para realizar una colposcopía y biopsia cervical son: Lesión cervical independiente del resultado de la prueba de Papanicolaou (PAP). PAP de tipo glandular, independientemente del grado. PAP escamoso de alto grado. Presencia del virus del papiloma humano (VPH) de alto grado, independientemente del resultado del PAP. PAP escamoso de bajo grado con VPH de bajo grado. Con lo anterior, se puede deducir el manejo de las ASCUS: existes 3 opciones: observar, controlar en 1 año y solicitar una prueba de VPH (la más aceptada). Si VPH(+): Se realiza colposcopía y biopsia, ya que cumple con el criterio de PAP de bajo grado más VPH de bajo grado. Si VPH(-): Se puede optar por la observación o un nuevo PAP en 6 a 12 meses. La opción más recomendada por las guías internacionales es solicitar un nuevo PAP. En menores de 25 años con ASCUS, también se solicita la prueba de VPH, pero se sigue en 1 (si VPH+) o 3 años (si VPH-).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 21 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y, desde entonces, mantener relaciones sexuales, con múltiples parejas, sin utilización de métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
B) Solicitar nuevo PAP en 6 años
C) Realizar colposcopía y eventual biopsia
D) Realizar conización cervical
E) Realizar histerectomía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El PAP de alto grado siempre va a colposcopía y biopsia. La tipificación de VPH no ha demostrado ser un buen examen y la guía Minsal solo lo tiene como opción ante el ASCUS (PAP de bajo grado) y no para el ASCH (alto grado).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 159 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una mujer tiene un PAP alterado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como lesión de bajo grado/VPH. ¿A qué evolucionará con mayor probabilidad esta lesión?

A) Involución espontánea
B) NIE 2
C) Carcinoma in situ
D) Condiloma acuminado
E) Cáncer de cuello uterino

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Involución espontánea). Las NIE 1 en su mayoría involucionan espontáneamente. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 11 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

PAP lesión de alto riesgo + VPH (+) 16 y 18: conducta

A) Colposcopia y eventual biopsia (esta no es cono)
B) Cono: según Guevara lesión de alto grado + VPH de alto grado es indicación de tratamiento al tiro (noo, LIE o VPH de alto grado son indicaciones por si solas de colpo + bx pero juntas no cambian la conducta, las únicas indicaciones de cono son NIE II, NIE III, Ca in situ y disociación colpocitológica)
C) Amoxicilina
D) Ibuprofeno
E) Paracetamol

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Colposcopia y eventual biopsia (esta no es cono)** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 76 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente de 30 años se realiza un PAP, que resulta atípico de alto grado, por lo que se realiza una colposcopía y biopsia, que es informada como NIE-1, de localización exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Seguimiento con PAP
B) Crioterapia
C) Cono cervical
D) Tipificación de virus papiloma humano
E) Diatermocoagulación

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Diatermocoagulación** (opción **E**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Seguimiento con PAP, Crioterapia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 60 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Mujer de 34 años con PAP que informa células glandulares atípicas (AGC). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Colposcopía con biopsia dirigida y legrado endocervical
B) Repetir PAP en 6 meses
C) Histerectomía total
D) Conización diagnóstica
E) Cepillado endocervical y repetir PAP en 3 meses

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Células glandulares atípicas (AGC) en PAP tienen mayor riesgo de lesión endocervical o endometrial significativa. Conducta: colposcopía + biopsia + legrado endocervical para descartar adenocarcinoma.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 58 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Mujer con PAP con NIE III y colposcopía normal con legrado endocervical normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Cono cervical
B) Crioterapia cervical
C) Seguimiento con PAP en 6 meses
D) Histerectomía simple
E) LEEP inmediato

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Cono cervical** (opción **A**). Cono cervical. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 165 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable lesión de bajo grado y presencia de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta mas adecuada?

A) Vacunar contra virus papiloma humano
B) Realizar colposcopía y biopsia
C) Repetir el PAP en 6 meses
D) Realizar hibridación para serotipos oncogénicos de virus papiloma
E) Realizar PAP en fase líquida en 1 a 3 meses

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Un PAP alterado, con probable lesión neoplásica, debe ir a colposcopía y biopsia, independiente del grado de las atipías celulares, más aún si hay VPH. La tipificación de VPH es cara, pero se recomienda, en caso de haber recursos (no es el caso de Chile), cuando hay una ASCUS (atipías celulares de significado incierto). La vacunación de VPH ya no sirve (se debe hacer antes de contraer el virus: en Chile se hace en 7° y 8° básico).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 112 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente de 32 años, se realiza citología cervical, que es informada como “presencia de células escamosas atípicas, sugerentes de NIE 3”. Se realiza colposcopía que no muestra lesiones y curetaje endocervical que es informado como “tejido endocervical normal”. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el curetaje endocervical
B) Controlar con nuevo Papanicolau en un año
C) Realizar histerectomía
D) Realizar conización cervical
E) Realizar legrado y biopsia endometrial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar conización cervical** (opción **D**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 173 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente se realiza un PAP que muestra atipías escamosas de bajo grado. Se realiza una colposcopía y biopsia, que muestra presencia de una neoplasia intraepitelial grado 1 y un condiloma. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Crioterapia
B) Tipificación de virus papiloma humano
C) Conización cervical
D) Histerectomía
E) Curetaje endocervical

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Crioterapia** (opción **A**). Tanto NIE 1, como condilomas, se tratan con crioterapia como primera línea.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 20 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente de 24 años se realiza un PAP que es informado como probable lesión de bajo grado, por lo que se realiza una colposcopía, que muestra una neoplasia intraepitelial de bajo grado. La conducta más adecuada es:

A) Controlar con PAP y colposcopía cada 6 meses
B) Tratar con diatermocoagulación bipolar
C) Tratar con crioterapia
D) Realizar cono cervical con asa LEEP
E) Realizar tratamiento con láser

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
A y C son respuestas aceptables pata el manejo de una NIE 1; también la tipificación, al menos, según la guía Minsal. Sin embargo, lo más importante siempre es el control periódico de la paciente con un PAP alterado y, por eso, lo dejaremos como la respuesta correcta.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 157 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente se realiza un PAP, que es informado como probable NIE-3, por lo que se realiza colposcopía, que no visualiza ninguna lesión exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar con nuevo PAP en un año
B) Realizar conización con asa LEEP
C) Realizar curetaje endocervical
D) Cono frío
E) Histerectomía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una disociación colpocitológica. Se debe realizar un cono biópsico o cono frío, ya que el cono con asa LEEP inutiliza la biopsia, porque quema la muestra.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 51 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente de 25 años, con antecedente de haber iniciado su vida sexual a los 14 años y, desde entonces, mantener relaciones sexuales, con múltiples parejas, sin utilización de métodos de barrera, se realiza un PAP que es informado como lesión de alto grado. Además, se realiza tipificación de virus papiloma humano, que muestra serotipo de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar nuevo PAP en 6 meses
B) Solicitar nuevo PAP en 1 año
C) Realizar colposcopía y eventual biopsia
D) Realizar cono LEEP
E) Realizar histerectomía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar colposcopía y eventual biopsia** (opción **C**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 12 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Disociación colpocitológica (PAP NIE III y colpo normal):

A) Cono
B) Volver a hacer legrado endocervical
C) Repetir en 6 meses
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (Cono). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Volver a hacer legrado endocervical, Repetir en 6 meses) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 52 3.01.1.016 · Enfermedad preinvasora del

Una paciente de 24 años se realiza un PAP, que es informado como lesión de bajo grado y probable infección de virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar PAP en 1 año
B) Realizar colposcopía y biopsia
C) Repetir el PAP en 6 meses
D) Realizar tipificación de virus papiloma humano
E) Realizar PAP en 3 meses

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discutible, ya que un PAP de bajo grado se puede controlar en 6 meses y también se puede tipificar el VPH: si es del ato grado (16 o 18), se envía a colposcopía; si es VPH de bajo grado, se observa y controla en 6 meses. Solo por la parte de la pregunta que dice "probable infección de VPH", nos inclinaremos por la opción de tipificarlo.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 87 3.01.1.028 · Tumores ováricos

Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal, de intensidad progresiva, que inició hace 4 meses. Ha bajado 5 kilogramos de peso. Al examen físico se observa abdomen distendido y destaca una masa anexial de 7 cm, de consistencia aumentada. El diagnóstico más probable es:

A) Quiste funcional
B) Mioma uterino
C) Cáncer de ovario
D) Cáncer de colon
E) Endometriosis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cáncer de ovario** (opción **C**). Es un cáncer de ovario clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 150 3.01.1.028 · Tumores ováricos

Una paciente de 55 años se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un chequeo ginecológico, que visualiza una lesión anexial derecha, quística, de 4,5 cm de diámetro, con una pared fina y sin tabiques ni excescencias. Su última regla fue hace 5 años. ¿Cuál es la

A) Realizar laparoscopía
B) Iniciar análogos de la GnRH
C) Realizar bipsia de la lesión por punción, guiada por ecografía
D) Iniciar anticonceptivos orales
E) Realizar seguimiento ecográfico en 3 meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

, ¿A? Es una pregunta muy difícil y en mi opinión es de manejo de especialista y tiene más de una opción de tratamiento. Tiene un quiste simple, en una mujer postmenopáusica. Se puede observar y controlar en 3 meses, dado que probablemente es benigno y actualmente muchos recomiendan observar los quistes simples de menos de 10 cm y solo operarlos si persisten sobre 5 cm a los 3 meses, por el riesgo de rotura y torsión. Sin embargo, algunos opinan que por tener más de 3 cm y ser postmenopáusica, también puede sacarse por laparoscopía. Yo marqué observar, a pesar del tamaño, dado que la pregunta hacía mucho énfasis en las características benignas del mismo.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 158 3.01.1.028 · Tumores ováricos

Una paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 6 meses de evolución. Al examen físico se palpa una masa anexial derecha, de 8 cm de diámetro, con ascitis significativa. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial, multiloculada, con increscencias y excrescencias. Su Ca- 125 resulta 700 UI/L. Se realiza un TAC que muestra engrosamiento peritoneal, probablemente de origen tumoral y se observa un tumor adosado a la pared gástrica y hepática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a cuidados paliativos
B) Terapia de reemplazo hormonal
C) Cirugía más quimioterapia
D) Quimioterapia paliativa
E) Tamoxifeno

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El cáncer de ovario avanzado, fuera de alcance curativo, se trata con QT paliativa. Pregunta para especialista. No debería hacerse en el Eunacom.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 173 3.01.1.028 · Tumores ováricos

Una paciente de 65 años, nulípara, asintomática, se realiza una ecografía tranvaginal, que muestra un tumor anexial izquierdo, de 23 mm, de aspecto quístico, con paredes lisas, sin tabiques ni excrecencias y sin presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar laparoscopía
B) Iniciar terapia de reemplazo hormonal
C) Solicitar marcadores tumorales
D) Realizar punción del quiste
E) Realizar control ecográfico en 3 meses

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta demasiado específica. Es un tumor anexial en una mujer postmenopáusica (históricamente todos se tratan con anexectomía por laparoscopía). Sin embargo los quistes simples menores a 3 cm se siguen con Ecografía por 3 meses. Si persisten se piden marcadores tumorales y se operan solo si están positivos, ya que de lo contrario solo se observan. Hay estudios recientes que muestran que los quistes anexiales simples son frecuentes en las mujeres postmenopáusicas y que solo una mínima parte evolucionan a cáncer. Los ginecólogos que contrataron para este examen tienen un claro problema. Esta pregunta no debería existir.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 165 3.01.1.028 · Tumores ováricos

Una paciente de 73 años presenta dolor abdominal moderado, en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, de 3 meses de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico, se palpa una masa en la fosa ilíaca izquierda y, al examen ginecológico, se palpa confirma la masa anexial izquierda, de consistencia dura y 8 cm de diámetro. ¿Cuál es el examen de elección para proseguir el estudio?

A) Ecografía abdominal
B) Ecografía transvaginal
C) Resonancia magnética de abdomen y pelvis
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Histerosonografía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (TAC de abdomen y pelvis). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecografía abdominal, Ecografía transvaginal) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 64 3.01.1.028 · Tumores ováricos

Mujer mayor con baja de peso, dolor abdominal y masa anexial palpable. ¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

A) TAC de abdomen y pelvis
B) RNM de pelvis con contraste
C) Marcadores tumorales (CA-125, HE4)
D) Ecografía transvaginal
E) PET-CT

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (Ecografía transvaginal). Ecografía transvaginal. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (TAC de abdomen y pelvis, RNM de pelvis con contraste) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 117 3.01.1.028 · Tumores ováricos

Una paciente de 32 años, nulípara, consulta por atraso menstrual de 7 semanas, por lo que solicita se corrobore si está embarazada. A la especuloscopía se observa moco cervical abundante, transparente y filante. Al tacto vaginal se objetiva útero de tamaño normal con una masa anexial de 7 cm, indolora y móvil. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Embarazo ectópico
B) Aborto retenido
C) Quiste folicular
D) Embarazo molar
E) Torsión ovárica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por tener moco filante, abundante y transparente, pues no está embarazada. En el embarazo el moco se seca rápidamente por acción de la progesterona. La torsión ovárica presenta dolor y no produce amenorrea. Los quistes foliculares son la causa más frecuente de tumor anexial en mujeres fértiles y se asocian a anovulación, como pareciera ser la causa del atraso menstrual.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 122 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Mujer de 55 años postmenopáusica con miomas uterinos conocidos. Llega a urgencias por metrorragia severa con hipotensión 90/60 mmHg y FC 118 lpm. ¿Cuál es el manejo inmediato?

A) Estabilización hemodinámica + histerectomía de urgencia
B) Ácido tranexámico EV y observar
C) Progestágenos EV en dosis alta
D) Embolización uterina electiva
E) Solo transfusión de GR y alta

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Sangrado uterino masivo con inestabilidad hemodinámica en postmenopáusica con miomatosis: prioridad = estabilización (fluidos + transfusión si necesario) + histerectomía de urgencia.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 144 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Pregunta 144 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 24 años, presenta metrorragia importante en el puerperio inmediato, dando salida a un flujo importante de sangre roja. Se palpa el fondo del útero por sobre el ombligo. ¿Cuál es la medida inicial más adecuada?

A) Metilergonovina
B) Misoprostol
C) Masaje uterino
D) Carbetocina
E) Oxitocina

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La medida inicial es el masaje uterino y luego rápidamente se inician los uterotónicos todos los que están en las opciones , habitualmente iniciando por la oxitocina y luego la metilergonovina.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 99 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Una paciente de 47 años, cuya FUR fue hace 55 días, presenta metrorragia de 10 días de evolución, abundante. Se solicita hemograma, que muestra hematocrito: 7,4 g/dl, blancos: 7.000. La conducta más adecuada es:

A) Realizar legrado uterino
B) Administrar progestágenos orales
C) Administrar estrógenos orales
D) Realizar histerectomía
E) Administrar estrógenos endovenosos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una metrorragia grave, anemizante. Por ello, se debe legrar para detener la hemorragia. Lo mismo aplica a las metrorragias graves, asociadas a compromiso hemodinámico. Los estrógenos sí se usan en las metrorragias disfuncionales, pero si es que no tienen ni anemia severa ni compromiso hemodinámico.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 53 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Una mujer de 42 años, diagnosticada de cáncer de cuello uterino en etapa IIIB, en tratamiento con quimioterapia y radioterapia combinada, consulta por abundante genitorragia. A su ingreso presenta PA: 100/60 mmHg y FC: 100x' y se realiza especuloscopía que confirma que el sangrado proviene de la lesión tumoral. Su hemograma muestra hemoglobina: 10 g/dl y hematocrito: 29%, con plaquetas de 170.000 por mm3. Se administra ácido tranexámico endovenoso y suero fisiológico. Sin embargo, la paciente continúa con abundante hemorragia. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar histerectomía
B) Administrar plasma fresco endovenoso
C) Realizar taponamiento vaginal
D) Realizar ligadura de las arterias cervicales
E) Realizar diatermocoagulación cervical

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La primera medida ante el CCU avanzado sangrante es taponar o el ácido tranexámico. La segunda es la que no se tomó. Además, se suele realizar radioterapia para disminuir la recidiva y la última opción es la histerectomía. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde este manejo.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 63 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Una paciente de 32 años, primigesta, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por metrorragia escasa. Su examen físico muestra PA: 120/70 mmHg, FC: 86x' y la especuloscopía se ven cuello cerrado, sin metrorragia actual. El monitoreo fetal no estresante resulta reactivo, con FCF basal de 144 lpm ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar betametasona 12 mg/día IM por dos veces
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Realizar cesárea
D) Solicitar una ecografía obstétrica
E) Realizar un tacto vaginal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las metrorragias de la segunda mitad del embarazo se estudian con ecografía obstétrica (diferencias placenta previa del DPPNI). Eso sí, si hay sufrimiento fetal, el examen más importante es el tacto vaginal, de modo de determinar la vía más expedita de parto.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 157 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Una paciente de 28 años, multípara de 1, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por metrorragia escasa. A la especuloscopía se ven restos de sangre, sin metrorragia actual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar amniocentesis
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Realizar cesárea
D) Solicitar una ecografía obstétrica
E) Realizar un tacto vaginal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar una ecografía obstétrica** (opción **D**). Las metrorragias de la segunda mitad del embarazo, se estudian con ecografía.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 163 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Una paciente de 34 años presenta hemorragia puerperal luego del parto. Recibe 10 unidades de oxitocina por vía endovenosa, pero persiste con hemorragia. Se palpa el útero por sobre el ombligo, blando. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar 10 UI de oxitocina por vía endovenosa
B) Administrar 0,2 mg de metilergonovina por vía intramuscular
C) Administrar 800 ug de misoprostol por vía rectal
D) Realizar ligadura de las arterias hipogástricas
E) Realizar exploración manual de la cavidad endometrial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pregunta muy muy discutible. Se pueden dar hasta 60 UI de oxitocina. También se puede dar la metilergonovina. El misoprostol se suele usar de segunda línea. Simultáneamente se hace una revisión instrumental del canal del parto, aunque también se puede hacer una revisión manual de la cavidad uterina y está indicada actualmente en toda hemorragia puerperal, incluso en las inercias uterinas clínicas, como es este caso.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 124 3.01.2.008 · Hemorragia genital aguda (

Una paciente, cursando embarazo de término, inicia contracciones uterinas intensas. Al examen obstétrico, se palpan 3 contracciones cada 10 minutos y dilatación cervical de 5 cm. Al romper las membranas, se produce metrorragia moderada, seguida de bradicardia fetal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rotura uterina
B) Desprendimiento de placenta normoinserta
C) Placenta previa
D) Rotura de vasa previa
E) Procidencia de cordón umbilical

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una rotura de vasa previa clásica (hemorragia con la rotura de membranas, asociada a sufrimiento fetal agudo y sin dolor ni afectación materna). La rotura uterina, además tiene dolor y antecedente de cesárea. El DPPNI además tiene contracciones dolorosas, hipertonía uterina. La placenta previa no puede ser, porque no habría habido salida de líquido ni afectación fetal. La procidencia de cordón no tiene metrorragia (sí tiene el sufrimiento fetal tras la rotura de membranas).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 42 3.01.5.006 · Evaluación intraparto

Embarazo de término, 4 cm de dilatación, cuello 100% borrado, MEFI con aceleraciones. ¿Cuál es la conducta?

A) Cesárea de urgencia
B) Amniotomía y oxitocina
C) Controlar en 2 horas
D) Aplicar gel de misoprostol intravaginal
E) Solicitar pH en calota fetal

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Controlar en 2 horas** (opción **C**). Controlar en 2 horas. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 58 3.01.5.006 · Evaluación intraparto

Una paciente de 31 años, en trabajo de parto de término, en fase activa, con progresión de 2 a 7 cm, en dos horas tiene dinámica de 3 contracciones en 10 minutos y membranas rotas. Se realiza registro cardiaco fetal, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable del estado fetal?

A) Registro tipo I
B) Registro tipo II
C) Registro tipo III
D) Registro reactivo
E) Variabilidad disminuida

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un MEFI I, por tener buena FCF, buena variabilidad y aceleraciones, sin desaceleraciones. Si no tuviese contracciones, sí podría ser la D, ya que se trataría de un RBNE (ver la clase de MEFI).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 169 3.01.5.006 · Evaluación intraparto

Una paciente embarazada de 38 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas. Al tacto vaginal tiene 3 cm de dilatación, con borramiento de 50% y presentación en vértice. Se realiza un registro cardiaco fetal, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar anestesia epidural
B) Realizar cesárea
C) Solicitar ecodoppler umbilical
D) Enviar a domicilio y pedirle que reconsulte en unas horas
E) Conducir el trabajo de parto

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El registro es tranquilizador (MEFI 1), por lo que se debe observar. Aún tiene muy poca dilatación, como para ponerle la anestesia (aunque algunos ya la indican con 3 cm), sin embargo la conducción del trabajo de parto me parece la respuesta más adecuada.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 84 3.01.5.006 · Evaluación intraparto

Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 39 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico, está en buenas condiciones generales, con dinámica uterina de 1 contracción en 10 minutos. El tacto vaginal comprueba cuello uterino 50% borrado, permeable a un dedo, con feto en cefálica, sin cambios respecto a un tacto vaginal, realizado hace 4 días. El monitoreo fetal no tiene alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Esperar a que inicie el trabajo de parto
B) Realizar cesárea
C) Inducir el parto con misoprostol
D) Hospitalizar y conducir el trabajo de parto
E) Realizar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Le faltan las modificaciones cervicales, por lo que aún no inicia el trabajo de parto. Es más, si tuviese dilatación hasta 3 cm, estaría en fase latente y también se envía a domicilio, indicando recontrol en una horas).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 169 3.01.2.016 · Dolor pélvico agudo

Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor ab- dominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su FUR fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la FII, con signos peritoneales esbozados. Se soli- cita test de embarazo, que resulta negativo y una ecografía transvaginal, que muestra una lesión anexial mixta de 8 cm de diámetro, con presencia de líquido libre en mode- rada cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cuerpo lúteo hemorrágico
B) Cuerpo lúteo roto
C) Apendicitis aguda
D) Torsión ovárica
E) Absceso tubo-ovárico

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Cuerpo lúteo hemorrágico** (opción **A**). Es un cuerpo lúteo heorrágico clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 175 3.01.2.016 · Dolor pélvico agudo

Una paciente de 17 años, que está en su día 16 del ciclo menstrual, consulta por dolor abdominal bajo, mayor al lado izquierdo. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Su examen ginecológico demuestra dolor a la palpación anexial izquierda y la ecografía transvaginal muestra un quiste anexial izquierdo, heterogéneo, con escaso líquido libre en el fondo del saco de Douglas. La conducta más adecuada es:

A) Controlar con ecografía postmenstrual
B) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
C) Solicitar marcadores tumorales
D) Realizar laparoscopía
E) Realizar laparotomía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una ovulación dolorosa, aunque podría estar transformándose en un cuerpo lúteo hemorrágico. También es pregunta difícil. Se debe controlar con ecografíay administrar analgésicos. Habitualmente desaparece el cuerpo lúteo simultáneamente a la menstruación.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 39 3.01.2.016 · Dolor pélvico agudo

Una paciente de 21 años, consulta por dolor hipogástrico de 4 días de evolución. Su FUR fue hace 2 semanas. Al examen físico, tiene dolor a la palpación profunda en el hipogastrio, sin signos peritoneales. En el examen ginecológico, tiene dolor a la palpación anexial derecha, sin otras alteraciones. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 15 mm, homogéneo, sin lesiones ni alteraciones anexiales ni líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear
B) Solicitar histerosalpingografía
C) Solicitar laparoscopía exploradora
D) Iniciar anticonceptivos orales y ácido mefenámico
E) Solicitar subunidad beta HCG

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar resonancia magnética nuclear** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 177 3.01.1.013 · Cáncer cervicouterino

Una paciente de 34 años consulta por genitorragia y sinusorragia, por lo que se realiza una especuloscopía, que muestra una lesión cervical ulcerada, friable. La conducta más adecuada es:

A) Colposcopía y biopsia
B) Conización cervical
C) Seguimiento ecográfico
D) Citología cervical
E) Buscar virus papiloma humano

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un probable cáncer de cuello uterino. Se debe biopsiar, idealmente en la colposcopía (aunque también se puede biopsiar directamente). El PAP (citología) ya no sirve

---

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 33 3.01.1.013 · Cáncer cervicouterino

Una paciente de 32 años se realizó un PAP hace dos años, que fue informado como “probable NIE 2”, sin embargo no tuvo controles posteriores. Hace un mes comienza con genitorragia escasa e intermitente, asociada a mal olor genital. Se realiza una especuloscopía, que visualiza una lesión de 2 cm de diámetro, en relación al cuello uterino, ulcerada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el PAP en este momento
B) Realizar biopsia de cuello uterino
C) Realizar histerectomía radical
D) Realizar un cono cervical
E) Solicitar prueba de detección y tipificación de virus papiloma humano

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar biopsia de cuello uterino** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 57 3.01.1.013 · Cáncer cervicouterino

Mujer con PAP con NIE III hace 3 años, sin controles, ahora con lesión exofítica ulcerada en cuello uterino. ¿Cuál es la conducta?

A) Colposcopía y tratamiento inmediato
B) CONO diagnóstico-terapéutico
C) Biopsia cervical
D) Histerectomía total
E) Repetir PAP y controlar en 3 meses

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Biopsia cervical** (opción **C**). Biopsia cervical. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 178 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar con nuevo PAP en un año
B) Indicar estrógenos tópicos
C) Solicitar colposcopía y biopsia
D) Realizar curejate endocervical
E) Solicitar ecografía transvaginal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Eco.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 166 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Paciente de 40 y tantos años con uso de ACO, suspendidos hace 2 semanas por gastritis. Inicia con sangrado hace 3 días?, eco con endometrio de 10 mm heterogéneo. Conducta más adecuada:

A) Suspender ACO y controlar en 3 meses
B) Legrado biópsico en pabellón
C) Biopsia aspirativa de forma ambulatoria.
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suspender ACO y controlar en 3 meses** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 81 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una paciente de 56 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg/día, por un cáncer de mama, diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia escasa desde hace 5 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexiales. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar terapia de reemplazo hormonal oral
B) Instalar dispositivo intrauterino medicado
C) Disminuir la dosis de tamoxifeno
D) Solicitar biopsia endometrial
E) Realizar histerectomía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una metrorragia posmenopáusica, que por tener un endometrio de 5 mm o más, debe biopsiarse con técnica Pipelle. El antecedente de tamoxifeno aumenta mucho el riesgo de cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial (premaligna).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 177 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una mujer de 62 años, con antecedente de 2 episodios de metrorragia autolimitada, en los últimos 3 meses, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 10 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar anticonceptivos orales
B) Realizar estudio de alteraciones de la hemostasia
C) Solicitar resonancia magnética de pelvis
D) Realizar biopsia endometrial
E) Observar evolución

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por tener metrorragia postmenopáusica, más un endometrio mayor o igual a 5 mm, se debe biopsiar (con TRH es mayor o igual a 9 mm).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 61 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Postmenopáusica con metrorragia y endometrio de 18 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Ecografía transvaginal en 3 meses
B) Histeroscopía diagnóstica
C) Legrado uterino bajo anestesia
D) Iniciar gestágenos y controlar
E) Solicitar biopsia endometrial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar biopsia endometrial** (opción **E**). Solicitar biopsia endometrial. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 11 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una paciente de 53 años, en tratamiento con tamoxifeno 20 mg/día, por un cáncer de mama, diagnosticado hace 9 años, presenta metrorragia desde hace 7 días, por lo que se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 8 mm, sin alteraciones anexiales. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar estrógenos orales
B) Iniciar progestágenos orales
C) Disminuir la dosis de tamoxifeno
D) Solicitar biopsia endometrial
E) Realizar histerectomía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El tamoxifeno aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. De todos modos, el manejo de la metrorragia postmenopáusica es estudiarla con una ecografía TV y luego biopsiar, si es que la ecografía no es compatible con una clara atrofia (endometrio menor a 4-5 mm o menor a 8 mm si está con TRH).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 147 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una paciente de 49 años, obesa, consulta por metrorragia de 10 días de duración, sin otros síntomas. Al examen físico destaca especuloscopía con sangre que proviene del OCE. Se solicita beta-HCG que resulta negativa y ecografía transvaginal, que mues- tra un endometrio de 15 mm de grosor. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis
B) Solicitar histerosalpingografía
C) Realizar estudio de alteraciones de la hemostasia
D) Realizar estudio de trombofilias
E) Realizar biopsia endometrial

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una metrorragia, sin embarazo y con Ecografía que muestra endometrio grueso. Además tienen antecedente de obesidad, que aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. P´or tanto, se debe biopsias.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 177 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una paciente de 58 años, menopáusica desde hace 10 años, sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por metrorragia de 5 días de evolución, de intensidad variable, con una cuantía total de 100 ml. Al examen físico se observa pálida, con PA: 100/60 mmHg y FC: 90x'. Se realiza especuloscopía, que muestra salida continua de sangre desde el orificio cervical externo. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?

A) Administrar anticonceptivos orales en alta dosis
B) Realizar legrado uterino de urgencia
C) Realizar histerectomía
D) Administrar ácido tranexámico
E) Realizar biopsia de endometrio

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Estudio de la Metrorragia Posmenopáusica: La metrorragia posmenopáusica se puede evaluar inicialmente mediante ecografía transvaginal o con biopsia endometrial. Si la ecografía muestra un endometrio menor o igual a 4 mm, se presume atrofia endometrial y no se realiza biopsia. Sin embargo, si el sangrado persiste o el endometrio es mayor a 4 mm, se indica la biopsia.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 62 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una mujer de 53 años, desde hace 3 meses presenta metrorragia intermitente, que ha aumentado. Su FUR fue a los 48 años y se realiza una ecografía transvaginal que muestra un mioma submucoso de 24 mm, otro subseroso de 52 mm, además, se visualiza su endometrio de 17 mm de grosor. La indicación más adecuada es:

A) Histerectomía
B) Estrógenos más progestágenos orales
C) Miomectomía
D) Biopsia de endometrio
E) Progestágenos orales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Los miomas son un hallazgo normal y no causan metrorragia. En cambio, el endometrio grueso asusta y debe ser biopsiado (descartar cáncer de endometrio o HPE). Recordar que igual se biopsian las metrorragias posmenopáusicas con un endometrio mayor a 5 mm (8 mm si tienen TRH), ya que si es mayor a esos grosores, es improbable que sea la atrofia (causa más frecuente).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 176 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una paciente de 43 años, multípara de 3, con antecedente de oligomenorrea, presenta metrorragia abundante, por lo que se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio engrosado, por lo que se realiza una biopsia endometrial por técnica de Pipelle, que demuestra presencia de hiperplasia endometrial compleja, con células atípicas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar anticonceptivos combinados orales
B) Indicar progestágenos orales en altas dosis
C) Realizar histerectomía total
D) Repetir el legrado
E) Indicar estrógenos orales en altas dosis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las hiperpasias endometriales atípicas y también las complejas se tratan con histerectomía, a menos que la paciente tenga altos deseos de paridad (en que se puede intentar un tratamiento alternativo: progestágenos y legrado). Es frecuente que en el Eunacom se pregunten varias veces lo mismo.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 175 3.01.1.024 · Patología maligna del endo

Una mujer de 65 años, nulípara, con IMC de 33, sin síntomas, se realiza un PAP que muestra abundantes células endometriales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar con nuevo PAP en un año
B) Indicar estrógenos tópicos
C) Solicitar colposcopía y biopsia
D) Realizar curejate endocervical
E) Solicitar ecografía transvaginal

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene factores de riesgo de cáncer de endometrio (HONDA; obesidad y nuliparidad) y además células endometriales. Se debe descartar una hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio, partiendo por la Ecografía y en caso necesario, con biopsia. Sin embargo, es importante aclarar que, en mujeres premenopáusicas, sin factores de riesgo, la presencia de células endometriales es algo estrictamente normal.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 50 3.01.4.004 · Ecotomografía obstétrica p

Una paciente de 32 años, con un embarazo de 12 semanas, se realiza una ecograFa obstétrica que revela una translucencia nucal mayor al percen8l 99 y ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnós8co?

A) Ecogra:a obstétrica de control a las 21 semanas
B) Estudio de ADN libre fetal en sangre materna
C) Amniocentesis con cariograma de sangre fetal
D) Biopsia de vellosidad corial
E) Determinación de niveles de alfa-fetoproteína y hCG

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Actualmente, la mejor forma de evaluar genopaVas fetales es con el ADN libre fetal en sangre materna, que es un examen seguro y más sensible y específico que la ecografía, razón por la cual muchas recomendaciones internacionales abogan por indicarlo como examen de primera línea y también como examen de segunda línea, si es que se usó otro, dejando los exámenes invasivos (biopsia de vellosidad corial y amniocentesis) únicamente para la confirmación definitiva. Sin embargo, la normativa chilena aún uGliza la ecografía 11-14 como prueba de screening (se hizo en este caso) y, si resulta con riesgo bajo (menor a 0,1% o menor a 1 en 1.000), se sigue el control habitual del embarazo; si Gene riesgo intermedio (1% a 0,1%, o 1 en 100 a 1 en 1.000), se recomienda seguir con el ADN libre fetal; y si Gene riesgo alto (> 1% o > 1 en 100), como en este caso que Gene alteraciones muy sugerentes, se debe ir directamente a la prueba invasiva. Por la edad gestacional corresponde la biopsia de vellosidad corial; la amniocentesis, en cambio se usa desde las 15 a 16 semanas.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 133 3.01.4.004 · Ecotomografía obstétrica p

Embarazada de 12 semanas con translucencia nucal aumentada en ecografía. ¿Cuál es el examen definitivo para confirmar trisomía 21?

A) Biopsia de vellosidades coriales (11-14 semanas)
B) Amniocentesis (15-20 semanas)
C) ADN fetal en sangre materna (NIPT)
D) Fetoscopia
E) Marcadores séricos maternos (triple marcador)

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

A las 12 semanas: biopsia de vellosidades coriales (BVC) es el examen invasivo de elección para cariotipo fetal (ventana 10-14 semanas). La amniocentesis se hace después de las 15 semanas.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 158 3.01.4.004 · Ecotomografía obstétrica p

Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 11 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra una translucencia nucal de 6 mm (VN: menor a 3 mm), asociada a ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia de vellosidad corial
B) Realizar amniocentesis a las 20 semanas
C) Realizar detección de ADN fetal en sangre materna
D) Realizar seguimiento con relación fémoro / craneana
E) Realizar el control normal del embarazo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El estudio de ADN fetal libre ha revolucionado el manejo de la detección de aneuploidías, por ser de mínimo riesgo y tener excelentes resultados (muy alta sensibilidad y muy bajos falsos positivos). Por tanto, en mi opinión es la respuesta correcta. Aunque sigue siendo algo que el médico general no tiene por qué hacer.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 75 3.01.4.004 · Ecotomografía obstétrica p

Una paciente de 41 años, cursando un embarazo de 11 semanas, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra translucencia nucal de 6 mm (VN: menor a 3 mm) y ausencia de hueso nasal. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Biopsia de vellosidad corial
B) Mediciones ecográficas seriadas de fémur
C) Repetir el examen a las 14 semanas
D) Estudio genético de DNA fetal libre en sangre materna
E) Niveles plasmáticos de HCG

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un alto riesgo de aneuploidía, tanto por edad materna, como especialmente por la TN mucho mayor a 3 y la ausencia de hueso nasal. Desde que existe el aborto por condiciones incompatibles con la vida, ha cobrado más relevancia el estudio genético, ya que, en caso de que sea incompatible con la vida (ej. trisomía 13 o 18), se debe ofrecer la opción de aborto a la madre. En cambio, la trisomía 21 es compatible con la vida y no tiene opción legal de aborto.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 18 3.01.4.004 · Ecotomografía obstétrica p

Una paciente de 40 años, cursando un embarazo de 24 semanas, se realiza ecografía obstétrica, que visualiza a los vasos umbilicales en las membranas amnióticas y al cordón umbilical, que se inserta en la zona marginal inferior de la placenta. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar una nueva ecografía el tercer trimestre
B) Observar evolución
C) Realizar rotura de membranas tardía
D) Realizar cesárea de inmediato
E) Administrar corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una inserción velamentosa cuyo manejo no debe realizar un médico general. Se asocia a rotura de vasa previa, al momento del parto, por lo que es correcto hacer cesárea (en el momento del parto o desde las 35 semanas), pero no ahora (a las 24 semanas), sino al término. Además, un porcentaje de los casos se resuelve a medida que avanza el embarazo, por lo que se debe confirmar con una nueva ecografía más adelante. La opción de observar evolución es correcta, pero en general da a entender que es algo completamente normal, en que no hay que hacer nada más, por lo que no la consideraremos correcta en esta pregunta.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 113 3.01.4.004 · Ecotomografía obstétrica p

Una paciente de 41 años, cursando un embarazo de 13 semanas, se realiza una eco- grafía transvaginal, que muestra regurgitación tricuspídea, con presencia de hueso na- sal, ductus venoso normal y traslucencia nucal de 1,9 mm (VN: menor a 3 mm). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Análisis genético de vellosidad corial
B) Amniocentesis biópsica
C) Ecocardiograma fetal
D) Estudio genético de DNA fetal libre en sangre materna
E) Niveles plasmáticos de HCG y alfafetoproteína

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Pésima pregunta. Quien sea que la haga hecho, por favor renuncie al Eunacom. Excede por demasiado lo que debe saber un médico general. Tiene un marcador aislado de aneuploidía (solo tenía la regurgitación mitral, pero estaba normal la traslucencia nucal, había hueso nasal presente y el ductus venoso estaba normal), por tanto, su pro- babilidad de aneuploidía es relativamente baja. Se debería controlar con una nueva Ecografía obstétrica en algunas semans más. De las opciones que aparecían, el ecocar- diograma fetal (que se realizaría después por un subespecialista) podría descartar pro- blemas cardiacos primarios. De las demás opciones, todas eran análisis genético (el de menos riesgo es el DNA libre fetal, pero no hay suficiente evidencia que lo recomiende).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 89 3.01.3.011 · Pubertad (adolescencia)

Una paciente de 14 años, con menarquia a los 13 años, presenta ciclos menstruales que varían entre 26 y 35 días. Su examen físico es normal y no refiere otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar anticonceptivos orales
B) Iniciar estrógenos solos por vía oral
C) Iniciar progestágenos solos por vía oral
D) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH y FSH
E) Controlar ambulatoriamente con calendario menstrual

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una adolescente normal, ya que sus ciclos son normales y además durante los primeros dos años postmenarquia es normal que haya ciclos irregulares.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 32 3.01.3.011 · Pubertad (adolescencia)

Una paciente de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Presenta desarrollo puberal Tanner 2, mamario y pubiano, con vello axilar. No tiene otras alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar ecografía ginecológica
B) Solicitar cariotipo
C) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH
D) Realizar prueba de progesterona
E) Controlar en un año

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es absolutamente normal. Como tiene desarrollo puberal, aún no se puede hablar de amenorrea primaria (se diagnostica a los 15 años si hay desarrollo puberal y se estudia con prueba de progesterona; en cambio, si no hay desarrollo puberal, se diagnostica a los 13 años y se estudia con muchas pruebas hormonales, ya que además hay un retraso puberal).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 54 3.01.1.015 · Endometriosis

Mujer de 38 años con dismenorrea severa, dispareunia profunda y menometrorragia. Ecografía transvaginal: útero aumentado de tamaño con ecotextura heterogénea, sin miomas definidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Endometriosis
B) Pólipo endometrial
C) Hiperplasia endometrial
D) Mioma uterino intramural
E) Adenomiosis

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Adenomiosis: endometrio ectópico dentro del miometrio → útero grande, globuloso, heterogéneo en ecografía + dismenorrea severa + menometrorragia + dispareunia. Afecta mujeres multíparas >35 años. Tratamiento: AINEs, gestágenos, DIU hormonal o histerectomía.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 136 3.01.1.015 · Endometriosis

Paciente femenina 50 años aprox o 38 años (alguien recuerda?), tiene antecedente de esterilización y adenomiosis ¿Cual es el manejo? a. Histerectomía con preservación de ovarios

A) Amoxicilina
B) Ibuprofeno
C) Paracetamol
D) Omeprazol
E) Metformina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Amoxicilina** (opción **A**). Tratamiento De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad. Las opciones alternativas (Ibuprofeno, Paracetamol) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 10 3.01.1.015 · Endometriosis

Una mujer de 32 años consulta por dismenorrea de 2 años de evolución, progresiva. Al examen ginecológico se palpa un tumor anexial derecho. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra un tumor ovárico derecho, de 6,5 cm de diámetro y aspecto quístico, en vidrio esmerilado. Su Ca-125 resulta 86 UI/L (VN: < 35 UI/L). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Carcinoma epitelial
B) Endometrioma ovárico
C) Teratoma maduro
D) Disgerminoma ovárico
E) Quiste folicular

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es un endometrioma clásico, tanto por la clínica como por la imagen. Además, tiene la elevación del Ca-125, que, si bien es un marcador de cáncer de ovario, se eleva en otros procesos peritoneales, como la endometriosis.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 53 3.01.1.015 · Endometriosis

Mujer de 18 años consulta por dismenorrea secundaria, intensa, de 6 meses de evolución que ha aumentado progresivamente, por lo que ha tomado AINEs y paracetamol sin respuesta. Su examen Fsico y ginecológico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar an2concep2vos orales
B) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de pelvis
C) Realizar laparoscopía diagnós2ca
D) Solicitar TAC de pelvis
E) Realizar histeroscopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy discuGble. La clínica orienta fuertemente a una endometriosis (dismenorrea secundaria, progresiva y refractaria), cuyo examen diagnóstico de elección es la laparoscopía (que también es terapéutica) y quien redactó la pregunta probablemente buscaba evaluar la capacidad de reconocer el cuadro clínico de la endometriosis. Sin embargo, aunque no está en las opciones, se recomienda iniciar el estudio con ecografía (que suele estar normal, salvo que haya un endometrioma) y también es correcto tratarla con anticonceptivos orales, ya que atrofian la endometriosis y no Genen el riesgo quirúrgico, por lo que muchas guías internacionales dejan la laparoscopía reservada a 1. No responde a AINES + ACO, 2. InferGlidad y 3. Endometrioma. De todos modos, en este caso, por la severidad de los síntomas y lo ya explicado, dejaremos como correcta la laparoscopía.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 47 3.01.1.015 · Endometriosis

Una paciente de 35 años, usuaria de dispositivo intrauterino, hace 9 años, consulta por un cuadro de dolor pélvico, que aumentó en la última menstruación. Se realiza ecografía transvaginal, que muestra una lesión quística de 6 cm en el ovario derecho, con contenido denso. Se solicitan niveles de Ca-125 que resultan 160 UI/ml (VN: menor a 35). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste folicular
B) Cáncer de ovario inicial
C) Quiste endometriósico
D) Cáncer de ovario avanzado
E) Teratoma ovárico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Quiste endometriósico** (opción **C**). Es un endometrioma clásico, que también puede llamarse quiste endometriósico.. Implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (peritoneo, ovarios, tabique recto-vaginal). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 70 3.01.1.015 · Endometriosis

Una paciente de 38 años, multípara de 2 con ambos hijos nacidos por cesárea y esterilización quirúrgica durante la última cesárea, consulta porque desde hace 8 meses presenta dolor en relación a las menstruaciones y aumento del flujo menstrual. Al examen físico tiene FC: 72x', PA: 110/70 mmHg, examen segmentario normal. El examen ginecológico se objetiva útero ligeramente aumentado de tamaño, blando y sensible a la palpación, sin otras alteraciones uterinas o anexiales. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

A) Dismenorrea primaria espasmódica
B) Adenomiosis
C) Proceso inflamatorio pélvico
D) Endometriosis
E) Miomatosis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Endometriosis** (opción **D**). Implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (peritoneo, ovarios, tabique recto-vaginal). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 60 3.01.1.015 · Endometriosis

Mujer con múltiples cesáreas previas, dismenorrea e hipermenorrea, útero aumentado de tamaño, blando y móvil. ¿Diagnóstico más probable?

A) Miomatosis uterina
B) Adenomiosis
C) Endometriosis pélvica
D) Enfermedad inflamatoria pélvica crónica
E) Síndrome adherencial postoperatorio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Adenomiosis** (opción **B**). Adenomiosis. Implantación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina (peritoneo, ovarios, tabique recto-vaginal). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 116 3.01.1.015 · Endometriosis

Una paciente de 40 años, multípara de 3, con el último parto por cesárea hace 1 año, consulta por dolor pélvico, en relación a la menstruación, asociado a flujo más abundante de lo habitual, que ha ido en aumento desde hace algunos meses. Al examen físico y ginecológico, se observan paredes vaginales normales y se palpa útero liso, de tamaño ligeramente aumentado, con anexos normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Miomatosis uterina
B) Endometriosis
C) Hiperplasia endometrial
D) Adenomiosis
E) Dismenorrea primaria

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una adenomiosis clásica: dismenorrea secundaria e hipermenorrea, con útero liso. La cesárea puede haberla facilitado. La miomatosis puede tener hipermenorrea, pero menos frecuente el dolor y el útero se suele palpar nodular. La endometriosis solo produce dolor, sin alteraciones del flujo menstrual. La hiperplasia endometrial produce metrorragias y es premaligna; se asocia a los factores de riesgo HONDA. La dismenorrea primaria es la que está presente desde las primeras menstruaciones.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 58 3.01.2.019 · Quiste ovárico torcido

Una paciente de 30 años consulta por dolor en la fosa iliaca derecha, que se ha asociado a vómitos alimentarios y que inició hace 48 horas. Al examen físico T°: 36°C, FC: 110x', PA: 110/70 mmHg. El examen abdominal muestra resistencia muscular involuntaria a la palpación de la fosa ilíaca derecha, con ruidos hidroaéreos conservados. Se realiza tacto vaginal, que resulta inconcluso debido a resistencia muscular. Se solicita una ecografía ginecológica transvaginal, que visualiza un tumor anexial derecho quístico multiloculado, de 10 cm de diámetro, con ausencia de flujo al Doppler color. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda
B) Embarazo ectópico
C) Proceso inflamatorio pélvico
D) Tumor anexial torcido
E) Cáncer de ovario

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Torsión ovárica: Aunque el cuadro clínico inicial puede asemejarse al de una apendicitis aguda, la presencia de un tumor anexial en la ecografía sugiere una torsión ovárica. El tamaño del tumor es un factor de riesgo importante: los tumores de más de 10 cm presentan el mayor riesgo, mientras que los que miden más de 5 cm tienen un riesgo intermedio. En este caso, incluso si el flujo Doppler color en la ecografía hubiera sido normal, la presencia de un tumor anexial grande en el contexto clínico descrito obliga a realizar una laparoscopía urgente, de modo de destorsionar el ovario inmediatamente y prevenir la necrosis ovárica.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 51 3.01.2.019 · Quiste ovárico torcido

Una paciente de 20 años, consulta por dolor intenso en la fosa iliaca izquierda, de 3 horas de evolución, que se ha asociado a vómitos. Al examen físico está afebril, con signos vitales normales y al examen abdominal presenta intenso dolor a la palpación de la fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg y resistencia muscular. No presenta atraso menstrual. Se solicita ecografía ginecológica, que muestra útero y ovario derecho normales y ovario izquierdo, con aumento de tamaño y presencia de un quiste de 6 x 4 cm, sin flujo al doppler y sin visualización de líquido peritoneal libre. El diagnóstico más probable es:

A) Endometrioma
B) Cuerpo lúteo hemorrágico
C) Quiste ovárico torcido
D) Teratoma ovárico
E) Embarazo ectópico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto la clínica (algia pélvica aguda intensa, con náuseas y vómitos), como la presencia de un tumor anexial (principal factor de riesgo), como el doppler alterado son muy sugerentes de torsión ovárica.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 63 3.01.2.019 · Quiste ovárico torcido

Mujer joven con dolor pélvico súbito, náuseas, vómitos y masa anexial dura de 7 cm al examen. ¿Diagnóstico más probable?

A) Quiste ovárico torsionado
B) Embarazo ectópico roto
C) Absceso tubo-ovárico
D) Mioma pediculado torsionado
E) Endometrioma roto

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Quiste ovárico torsionado** (opción **A**). Quiste ovárico torsionado. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 162 3.01.2.019 · Quiste ovárico torcido

Paciente femenina, en su día 10 de ciclo menstrual, dolor abdominal súbito, con tumor anexial 7 cm, diagnóstico mas probable

A) Torsión ovárica
B) Endometrioma
C) Diverticulitis aguda
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Torsión ovárica** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 113 3.01.2.019 · Quiste ovárico torcido

Una paciente de 24 años, usuaria de anticonceptivos orales, cuya última regla fue hace 8 días, consulta por dolor en la fosa ilíaca derecha, de inicio súbito, intenso, que se ha asociado a náuseas y vómitos alimentarios, en una oportunidad. Al examen físico, tiene FC: 88x', PA: 120/78 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha y del hipogastrio. Al examen ginecológico, además, se palapa una masa anexial derecha de 6 cm. Se solicita ecografía transvaginal, que visualiza útero de tamaño y paredes normales, endometrio de 6 mm de diámetro, presencia de una lesión anexial derecha quística de 6 cm, sin líquido libre, además, no es posible visualizar el apéndice cecal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Absceso tubo ovárico
B) Apendicitis aguda
C) Quiste ovárico torcido
D) Embarazo ectópico
E) Vólvulo de ciego

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Quiste ovárico torcido** (opción **C**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 175 3.01.2.019 · Quiste ovárico torcido

Una niña de 17 años, con antecedente de menarquia a los 15 años y cuyas reglas son irregulares, cada 30 a 40 días. Consulta por dolor pélvico muy intenso, asociado a sudoración y vómitos. Al preguntarle dirigidamente, niega actividad sexual. Al examen físico se observa adolorida, quejumbrosa y se palpa una masa hipogástrica de 7 cm de diámetro, muy dolorosa. El diagnóstico más probable es:

A) Cáncer de ovario
B) Absceso tuboperitoneal
C) Síntomas de aborto
D) Torsión anexial
E) Pelviperitonitis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Torsión anexial** (opción **D**). Parece una torsión ovárica clásica: dolor intenso, asociado a vómitos, de inicio súbito.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 120 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 68 años, nulípara, con antecedente de menopausia a los 50 años, consulta debido a sangrado genital intermitente de 2 meses de evolución, con cuantía variable. Se realiza una ecografía transvaginal que muestra un endometrio de 13 mm de grosor de aspecto heterogénea, con áreas microquísticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hiperplasia endometrial
B) Miomatosis endometrial
C) Atrofia endometrial
D) Pólipo endometrial
E) Cáncer de endometrio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Hiperplasia Endometrial: El endometrio grueso e irregular es una característica tanto de la hiperplasia endometrial como del cáncer de endometrio. Sin embargo, la descripción de un aspecto heterogéneo con áreas microquísticas se observa con mayor frecuencia en la hiperplasia endometrial, por lo que esta es la respuesta correcta. Eso sí, la conducta es realizar una biopsia de endometrio para confirmar el diagnóstico y descartar el cáncer. La hiperplasia simple se trata con progestágenos. La hiperplasia atípica, en cambio, se trata con histerectomía.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 124 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Pcte de 39 años con metrorragia e hipermenorrea, eco con endometrio homogéneo y masa en fondo uterino, conducta:

A) histeroscopia (segun yo tmbn x4, obs pólipo endometrial)
B) biopsia endometrial
C) Observación clínica
D) Derivar a urgencia
E) Control ambulatorio

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **histeroscopia (segun yo tmbn x4, obs pólipo endometrial)** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 49 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Mujer con sangrado intermenstrual; ecografía muestra pólipo endometrial de 15 mm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Legrado uterino diagnóstico-terapéutico
B) Anticonceptivos orales para control del sangrado
C) Seguimiento ecográfico en 6 meses
D) Realizar histeroscopia
E) Histerectomía

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar histeroscopia** (opción **D**). Realizar histeroscopia. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 37 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 35 años, nulípara, sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta porque desde hace 6 meses ha presentado aumento del flujo menstrual. Su examen físico no aporta mayor información. Tiene PAP sin presencia de células atípicas, realizado hace 8 meses. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra la presencia de un pólipo endometrial de 8 mm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar histerosonografía
B) Realizar histerectomía
C) Realizar histeroscopía
D) Realizar legrado uterino
E) Iniciar anticonceptivos orales

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar histeroscopía** (opción **C**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Realizar histerosonografía, Realizar histerectomía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 52 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 56 años de edad presenta metrorragia abundante, que se maneja con legrado. Se envía a biopsia, que es informada, como hiperplasia endometrial compleja, sin atipías. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Controlar con ecografía en 6 meses
B) Solicitar resonancia magnética nuclear de pelvis
C) Iniciar progestágenos orales
D) Realizar histerectomía total
E) Iniciar estrógenos orales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por el alto riesgo de cáncer, la HPE compleja, la HPE atípica y la HPE compleja y atípica se manejan todas con histerectomía, a menos que la paciente tenga muchos deseos de paridad, en que se intenta un tratamiento combinado de legrado y progestágenos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 36 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 53 años, en terapia de remplazo hormonal combinada oral, desde hace 6 meses, presenta metrorragia de 3 días de evolución, escasa. Su examen físico no tiene alteraciones y en la especuloscopía se aprecian restos de sangre en el orificio cervical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atrofia endometrial
B) Pólipo endometrial
C) Hiperplasia endometrial
D) Cáncer de endometrio
E) Metrorragia disfuncional

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tanto por la edad como por el uso de TRH combinada, que tiene progestágeno, lo más probable es una atrofia endometrial.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 172 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 80 años, se realiza una ecografía transvaginal, como parte de un control ginecológico, que muestra un endometrio de 7 mm, con anexos normales. No presenta síntomas y no recibe terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Histerectomía
B) Terapia de reemplazo hormonal
C) Biopsia de endometrio si es que presenta metrorragia
D) Legrado
E) Colposcopía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un endometrio grueso para su edad, por lo que podría tener una hiperplasia endometrial y eventualmente desarrollar un cáncer. Sin embargo, por estar asintomática, se debe observar. De las opciones, la C era la más aceptable.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 42 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 56 años, en terapia de remplazo hormonal combinada oral, desde hace 5 años, presenta metrorragia de 3 días de evolución, escasa. Su examen físico no tiene alteraciones y en la especuloscopía se aprecian restos de sangre en el orificio cer- vical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Atrofia endometrial
B) Pólipo endometrial
C) Hiperplasia endometrial
D) Cáncer de endometrio
E) Metrorragia disfuncional

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una atrofia endometrial clásica (menopáusica y autolimitada). Además, la TRH combinada, por tener progestágeno, igual puede producir atrofia.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 97 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Mujer 54 años obesa, diabética e hipertensa, presenta hace 3 meses genitorragia intermitente, con antecedentes de menopausia a los 50 años, sin terapia hormonal de reemplazo y PAP normal de este año. El examen físico y ginecológico es normal. Se realiza una Ecografía tranvaginal, que muestra: útero en anteversoflexión, con tamaño normal, endometrio homogéneo de 3 mm de grosor, con anexos normales, sin liquido libre. ¿Cual es el diagnóstico más probable?

A) Hiperplasia endometrial.
B) Cáncer endometrial
C) Pólipo endometrial
D) Atrofia endometrial.
E) Sarcoma uterino

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien, tiene los antecedentes que orientan a hiperplasia endometrial o cáncer (HONDA: hipertensión arterial, obesidad, nuliparidad, diabetes y anovulación), el grosor del endometrio es un muy fuerte indicador de atrofia endometrial (menor a 5 mm se observa), que es la causa más frecuente de metrorragia postmenopáusica.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 107 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 56 años de edad presenta metrorragia abundante, que requiere de legrado. Se envía a biopsia, que es informada, como hiperplasia endometrial atípica y compleja. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Anticonceptivos combinados
B) Solicitar niveles de estradiol y FSH
C) Progestágenos orales en altas dosis
D) Histerectomía total
E) Progestágenos endovaginales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La HPE atípica (en especial si es compleja) se trata con histerectomía, porque tiene alto riesgo de evolucionar a un cáncer de endometrio. La HPE simple se trata con progestágenos orales o con el DIU medicado.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 150 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 46 años, nulípara, sin método anticonceptivo, presenta una metrorragia, que es manejada con legrado uterino. La biopsia demuestra presencia de hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el legrado en 3 meses
B) Implantar DIU medicado con progestágenos
C) Realizar histerectomía total
D) Indicar progestágenos cíclicos
E) Indicar progestágenos continuos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La hiperplasia atípica se trata con histerectomía. Si bien la paciente es nulípara, a los 46 años es improbable que se le indique un tratamiento más conservador, ya que probablemente no tendrá más hijos. De todos modos, en la vida real, se debe consultar la opinión de la paciente, ya que, si sus deseos de fertilidad son importantes, se puede hacer una hormonoterapia con progestágenos y reevaluar con biopsia endometrial. La hiperplasia endometrial simple, en cambio, se trata con progestágenos.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 106 3.01.1.023 · Patología benigna del endo

Una paciente de 58 años, consulta por metrorragia de 3 días evolución. Su examen ginecológico demuestra escasa metrorragia, que proviene del OCE, sin otras alteraciones. Sus mamografías y PAP son normales y fueron realizados hace menos de un año. Se realiza una ecografía transvaginal, que muestra endometrio de 3 mm, sin masas, ni otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar colposcopía
B) Controlar con una ecografía en 3 meses
C) Realizar legrado
D) Iniciar terapia de reemplazo hormonal combinada
E) Realizar biopsia de endometrio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una probable atrofia endometrial (metrorragia postmenopáusica, con EM menor a 5 mm), por lo que se observa y controla.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 80 3.01.1.025 · Proceso inflamatorio pelvi

Una paciente de mantiene actividad sexual, sin método anticonceptivo, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal de 3 días de evolución. Al examen físico presenta abdomen sensible y al examen ginecológico destaca útero doloroso, tanto a la palpación, como a la movilización. Se solicitan exámenes, que muestran test de embarazo negativo, hemograma con leucocitos: 18.000 por campo y PCR: 8,0 mg/L. La ecografía transvaginal muestra presencia de líquido libre escaso en la cavidad peritoneal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar tratamiento sintomático con ácido mefenámico
B) Realizar cultivo endocervical
C) Indicar anticonceptivos orales
D) Iniciar tratamiento antibiótico
E) Realizar laparotomía exploradora

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un proceso inflamatorio pélvico, no complicado, por lo que se trata con antibióticos de amplio espectro.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 174 3.01.1.025 · Proceso inflamatorio pelvi

Una paciente de 26 años, sexualmente activa, consulta por disuria y dolor abdominal bajo, que luego se extiende al hipocondrio derecho y se asocia a leucorrea. Al examen físico tiene dolor a la palpación hipogástrica y del hipocondrio derecho y, en el examen ginecológico, se constata leucorrea, sin mal olor. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

A) Enterococcus faecalis
B) Ureaplasma Urealyticum
C) Chlamydia trachomatis
D) Treponema pallidum
E) Mycoplasma genitalium

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un PIP clásico, con la perihepatitis (síndrome de Fitz-Hugh-Curtis), que habitualmente es causado por Chlamydia trachomatis o por gonococo.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 152 3.01.1.025 · Proceso inflamatorio pelvi

Una paciente de 25 años, sexualmente activa, que no utiliza métodos de barrera, consulta por fiebre, asociada a dolor abdominal, disuria, polaquiuria y leucorrea. Al examen físico presenta temperatura 38 grados, dolor a la palpación abdominal, mayor en la fosa ilíaca derecha. Además, en el examen ginecológico se observa leucorrea y tiene dolor a la palpación bimanual. El agente etiológico más probable es:

A) Escherichia coli
B) Gardnerlla vaginalis
C) Trichomona vaginalis
D) Estreptococo grupo A
E) Gonococo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **E** (Gonococo). Tiene un PIP clínico, cuya causa clásica es el gonococo.. :::note El metronidazol en monodosis de 2 g es la elección para tricomoniasis, NO para vaginosis. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 42 3.01.3.001 · Control prenatal

Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 42 semanas acude a control. No presenta dinámica uterina y la altura uterina es acorde a la edad gestacional. Los la8dos cardiofetales son de 125 lpm. Se realiza ecograFa obstétrica que es8ma un peso fetal de 3.600 g, y visualiza un bolsillo mayor de líquido amnió8co de 3 cm. El Doppler fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Citar a control en 3 días
B) Citar para inducción del parto en 3 días
C) Inducir el parto en este momento con misoprostol
D) Realizar cesárea
E) Solicitar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Desde las 42 semanas se considera un embarazo postérmino, con riesgos asociados (sufrimiento fetal el más importante) y se debe interrumpir. Si está todo bien (como en este caso), la vía de elección es vaginal. De hecho, se recomienda interrumpir desde las 41 semanas y se considera aceptable hacerlo desde las 39 semanas, ya que no se ha visto mayor riesgo en hacerlo. En resumen, 42 semanas: "se debe"; 41 semanas: "se recomienda"; 39 semanas "se acepta" interrumpir.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 17 3.01.3.001 · Control prenatal

Glucosuria en embarazo de 24 semanas con HGT normal es indicativo de a. Normal

B) Hallazgo precoz de preeclampsia
C) Hallazgo precoz de daño renal crónico
D) Hallazgo de alteración de tubo proximal (no recuerdo muy bien)
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Hallazgo precoz de preeclampsia, Hallazgo precoz de daño renal crónico) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 95 3.01.3.001 · Control prenatal

¿Como es la suplem nientación con ácido fólico en embarazo según la guía perinatal?: a. 3 meses preconcepcional hasta las 12 semanas de edad gestacional

A) Interrupción del embarazo
B) Maduración pulmonar y observación
C) Cesárea de urgencia
D) Inducción del parto
E) Control prenatal habitual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Interrupción del embarazo). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Maduración pulmonar y observación, Cesárea de urgencia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 38 3.01.3.001 · Control prenatal

Una paciente de 25 años, vegana estricta, con antecedente de parto hace 6 meses, con un hijo con mielomeningocele, consulta porque desea planificar un nuevo embarazo. ¿Qué suplemento alimen8cio debe indicarse de manera prioritaria?

A) Vitamina B12
B) Ácido fólico
C) Calcio
D) Hierro
E) Ácidos grasos omega-3

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta difícil, ya que la dieta vegana se asocia principalmente a déficit de vitamina B12, que debe ser suplementada y cuya deficiencia también se asocia a defectos del tubo neural. Además, en Chile, el ácido fólico está presente en las harinas, por lo que su deficiencia es muy rara. Sin embargo, ante un antecedente de defectos del tubo neural, sin duda alguna, lo más importante es suplementar folatos en dosis altas (4 mg al día vs. 0,4 mg al día en pacientes sin factores de riesgo). Se debe iniciar idealmente 3 meses antes del embarazo, hasta la semana 12 de gestación. Las dosis altas también se indican en pacientes diabéticas embarazadas o que desean embarazarse.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 163 3.01.3.001 · Control prenatal

Una pareja consulta porque hace un año tuvieron una interrupción de un embarazo, debido a que el feto tenía anencefalia. Desde entonces ella ha tomado anticonceptivos, sin embargo, ahora quieren intentar un nuevo embarazo.. Él tiene 38 años y ella 35. Como antecedente ella tiene diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, sin tratamiento y él tiene un hermano con trisomía 21. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cariograma a ambos
B) Iniciar levotiroxina a la mujer
C) Solicitar espermiograma al hombre
D) Iniciar ácido fólico 4 mg al día desde 3 meses antes al embarazo a la mujer
E) Solicitar anticuerpos antifosfolípido a la mujer

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Iniciar ácido fólico 4 mg al día desde 3 meses antes al embarazo a la mujer** (opción **D**). El hipotiroidismo se presenta con astenia, adinamia, intolerancia al frío, constipación, piel seca, bradipsiquia, caída de la cola de las cejas, bradicardia e hipotermia en casos severos, hiporreflexia y alteraciones de laboratorio como anemia macrocítica, hiponatremia con VEC normal, hiperbilirrubinemia indirecta, dislipidemia (hipercolesterolemia) y aumento de CK. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 38 3.01.3.001 · Control prenatal

Mujer que quiere embarazo, con antecedente de hijo con anencefalia y TSH levemente elevada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tratar hipotiroidismo y luego iniciar ácido fólico 0,4 mg/día
B) Ácido fólico 0,4 mg/día desde ahora
C) Derivar a neurología fetal antes de planificar embarazo
D) Iniciar ácido fólico 4 mg/día 3 meses previo al embarazo
E) Solicitar TORCH y estudio genético previo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar ácido fólico 4 mg/día 3 meses previo al embarazo** (opción **D**). Iniciar ácido fólico 4 mg/día 3 meses previo al embarazo. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 39 3.01.3.001 · Control prenatal

Embarazada de 35 semanas con cultivo para Estreptococo grupo B positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar amoxicilina oral por 10 días ahora
B) Iniciar penicilina endovenosa durante el trabajo de parto
C) Erradicar con clindamicina vaginal
D) Repetir cultivo a las 37 semanas
E) No requiere tratamiento adicional

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Iniciar penicilina endovenosa durante el trabajo de parto** (opción **B**). Iniciar penicilina endovenosa durante el trabajo de parto. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 62 3.01.3.001 · Control prenatal

Una mujer de 35 años desea embarazarse. Como antecedentes tiene hipertensión, resistencia a la insulina, hipotiroidismo y depresión. Está en tratamiento con enalapril, levotiroxina, sertralina y metformina, a lo que agregó ácido fólico 1 mg/día. ¿Cuál es el consejo preconcepcional más adecuado?

A) Disminuir la dosis de metformina
B) Aumentar la dosis de levotiroxina
C) Cambiar el enalapril por otro antihipertensivo
D) Suspender la sertralina
E) Aumentar la dosis de ácido fólico a 4 mg/día

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los HGO se pueden mantener actualmente en el embarazo. La levotiroxina sí se aumentará probablemente cerca de un 30%, de modo de lograr el objetivo de TSH entre 0,4 y 2,5. Sin embargo, los antiHTA son teratogénicos y se deben cambiar por alfametildopa. El ácido fólico se debe dar 0,4 mg/día, a menos que sea diabética o tenga antecedentes de defectos del tubo neural, en que se sube a 4 mg/día.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 89 3.01.3.001 · Control prenatal

Una mujer de 28 años, cursando un embarazo de 18 semanas, educadora de párvulos, estuvo en contacto con un niño con varicela. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Solicitar serología materna
B) Administrar gamaglobulina hiperinmune
C) Indicar licencia médica por 21 días
D) Iniciar valaciclovir
E) Observar evolución

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se debe solicitar la serología: IgG antivaricela. Si está positiva, no hay riesgo. Si está negativa, se indica la gamaglobulina hiperinmune, por tener menos de 20 semanas.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 153 3.01.3.001 · Control prenatal

Una mujer de 35 años desea embarazarse. Como antecedentes es hipertensa, diabética, hipotiroidea y depresiva. Está en tratamiento con enalapril, levotiroxina, fluoxetina, metformina y ácido fólico. ¿Cuál es el consejo preconcepcional más adecuada?

A) Suspender la metformina
B) Aumentar la dosis de levotiroxina
C) Cambiar el enalapril por otro antihipertensivo
D) Suspender la fluoxetina
E) Mantener los medicamentos, sin cambios

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por ser diabética, debe recibir dosis de 4 mg de ácido fólico al día. Si bien la recomendación chilena, dice que se prefiere la insulina, por sobre los HGO, la evidencia ha demostrado que tanto MTF, como GBC son tan seguros como la insulina. Además, debe suspender el enalapril y cualquier otro antihipertensivo y cambiarlo por alfametildopa.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 52 3.01.3.001 · Control prenatal

Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 36 semanas, se realiza una prueba de detección de estreptococo betahemolítico grupo B, mediante cultivo obtenido por tórula perineal, el que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada para prevenir la infección del recién nacido?

A) Tratar a la madre con amoxicilina oral por 7 días en este momento
B) Tratar a la madre con penicilina endovenosa durante el trabajo de parto
C) Tratar al recién nacido con ampicilina endovenosa durante la primera hora de vida
D) Inducir el parto en este momento
E) Realizar operación cesárea al llegar a término

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Tratar a la madre con penicilina endovenosa durante el trabajo de parto** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 117 3.01.3.001 · Control prenatal

Embarazada menor de 20 semanas, parvularia, con contacto con niño con varicela. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar inmunoglobulina antivaricela de inmediato
B) Administrar vacuna de varicela
C) Solicitar serología materna (IgG anti-varicela)
D) Indicar aciclovir oral profiláctico
E) Hospitalizar y observar

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar serología materna (IgG anti-varicela)** (opción **C**). Solicitar serología materna (IgG anti-varicela). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 30 3.01.3.001 · Control prenatal

Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 8 semanas, tiene antecedente de haber sufrido una trombosis venosa profunda, hace 5 años, en relación al uso de anticonceptivos orales. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Iniciar antiagregantes orales
B) Iniciar anticoagulación oral
C) Realizar estudio de trombofilia
D) Iniciar heparina de bajo peso molecular
E) Solicitar ecografía Doppler de extremidades inferiores

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si se anticoagula en el embarazo, se prefiere que sea con heparina de bajo peso molecular, ya que los anticoagulantes orales son teratogénico y aumentan el riesgo de sangrado en el parto. El antecedente de una TVP no necesariamente obliga a anticoagular a una embarazada, a menos que 1. tenga una trombofilia ya identificada (ej. déficit de ATIII o mutación de la protrombina) o 2. la TVP haya tenido relación con algo hormonal, como el embarazo, puerperio o inicio de ACO, como en este caso.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 179 3.01.3.001 · Control prenatal

Una paciente tiene antecedente de una trombosis venosa profunda, hace 4 años, en relación al inicio de anticonceptivos orales, la que fue tratada con anticoagulación oral por 6 meses. Consulta por un embarazo de reciente diagnóstico. ¿Cuál es el manejo de elección?

A) Iniciar antiagregantes plaquetarios
B) Realizar estudio de trombofilia
C) Iniciar heparina de bajo peso molecular
D) Iniciar ácido tranexámico
E) Iniciar tratamiento anticoagulante oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

[Pregunta disputada] Es una mala pregunta, ya que lo ideal es contar con un estudio de trombofilia (las guías gringas lo recomiendan, aunque en el embarazo es un mal mometo para hacerlo). Sin embargo, por haber sido una TVP relacionada a los estrógenos, creo que lo mejor será anticoagularla durante el embarazo, con heparina de bajo peso.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 55 3.01.3.004 · Lactancia

Puérpera en su 10° día con PCR SARS-CoV-2 positivo y síntomas leves. ¿Cuál es la conducta respecto a la lactancia?

A) Suspender lactancia hasta completar 10 días de aislamiento
B) Mantener la lactancia con uso de mascarilla
C) Extraer leche y pasteurizar antes de dar al bebé
D) Suspender lactancia y cambiar a fórmula
E) Mantener lactancia sin restricciones

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener la lactancia con uso de mascarilla** (opción **B**). Mantener la lactancia con uso de mascarilla. Fisiología De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 68 3.01.3.004 · Lactancia

Una paciente es diagnosticada de Covid-19, con inicio de síntomas hace 10 días, mientras cursaba un embarazo de término, manteniendo solo algún grado de tos. Presentó parto vaginal hace dos horas, con recién nacido sano y su puerperio inmediato ha sido normal hasta ahora. ¿Qué recomendación se debe dar acerca del momento en el que se debe iniciar la lactancia materna?

A) Posponerla hasta tener la madre una PCR SARS-Cov2 negativa
B) Posponerla hasta que se hayan cumplido 14 días desde el diagnóstico
C) Posponerla hasta que se hayan cumplido 28 días desde el diagnóstico
D) Iniciarla de inmediato con mascarilla
E) Iniciarla de inmediato sin protección

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Posponerla hasta que se hayan cumplido 28 días desde el diagnóstico). :::note Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 127 3.01.3.004 · Lactancia

Una mujer puérpera hace 5 semanas, dando lactancia materna exclusiva, consulta por dolor y enrojecimiento del pezón izquierdo. Al examen físico se muestra lo siguien- te: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Mupirocina tópica
B) Clotrimazol tópico
C) Óxido de zinc tópico
D) Lanolina purificada tópica
E) Betametasona tópica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Eran grietas del pezón, que si bien no tienen un tratamiento claro, más allá de mejorar la técnica de lactancia materna, se suele tratar con lanolina.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 160 3.01.3.004 · Lactancia

Una paciente, puérpera desde hace 10 días, presenta dolor en la mama derecha, que aumenta especialmente al dar de mamar. En su examen físico se aprecia lo siguiente: FOTO (punto blanco o perla láctea en el pezón). ¿Cuál es la indicación más adecuada?

A) Frío local antes de dar de mamar
B) Calor
C) Punción de la lesión
D) Drenaje quirúrgico
E) Uso de pezonera

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

, C? Tiene un punto blanco o perla láctea, que se produce porque se obstruye la salida de uno de los conductos galactóforos. Su tratamiento es discutible, ya que responde a distintos tratamientos y además, puede estar infectado. El calor local es lo clásico, pero también se suelen puncionar, ya que así se soluciona el problema. En mi opinión, es una mala pregunta, ya que tiene más de una respuesta correcta. Yo marqué puncionar, pero probablemente la respuesta que consideren como correcta es la del calor local. De verdad que Asofamech debería publicar sus preguntas y respuestas, para poder solucionar este tipo de preguntas.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 37 3.01.3.004 · Lactancia

Una paciente de 30 años, con antecedente de parto hace 3 meses y que está en lac- tancia materna exclusiva, consulta por dispareunia intensa. Al examen físico se aprecia la mucosa vaginal pálida y muy seca. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar antimicóticos orales
B) Iniciar metronidazol oral
C) Iniciar anticonceptivos combinados orales
D) Iniciar ceftriaxona intramuscular más azitromicina oral
E) Indicar lubricante genital

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un hipoestrogenismo postparto. No suele ser grave, por lo que basta el uso de lubricación. Además, por estar en lactancia, están contraindicados los estrógenos (cortan la lactancia).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 157 3.01.3.015 · Síndrome de ovario poliquí

Mujer de 28 años con amenorrea de 4 meses, hirsutismo, acné y obesidad central. Ecografía: ovarios con múltiples folículos periféricos. Testosterona libre levemente elevada. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
B) Hiperprolactinemia
C) Insuficiencia ovárica prematura
D) Síndrome de Cushing
E) Hiperplasia suprarrenal congénita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Amenorrea + hiperandrogenismo (hirsutismo, acné, testosterona elevada) + ecografía con patrón poliquístico = SOP (criterios de Rotterdam: 2 de 3 criterios). Causa más frecuente de amenorrea secundaria en mujeres jóvenes.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 175 3.01.3.015 · Síndrome de ovario poliquí

Una mujer de 18 años, presenta reglas regulares, muy abundantes, asociada a dismenorrea. Se realiza una ecografía transvaginal, que visualiza múltiples quistes menores a 6 mm en ambos ovarios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia de endometrio
B) Realizar histeroscopía
C) Solicitar estudio endocrinológico
D) Solicitar test de tolerancia a la glucosa
E) Solicitar estudio de la hemostasia

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

, E? Nuevamente es una mala pregunta. Por un lado, tiene la hipermenorrea, sin una causa anatómica, por lo que se debe estudiar la hemostasia. Por otro lado, tiene el criterio ecográfico de SOP, por lo que se debe buscar el criterio endocrinológico, con el índice de andrógenos libres. Yo marqué C, pero como el Eunacom no tiene transparencia, nunca sabremos cuál es la respuesta.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 59 3.01.4.007 · Papanicolau

Mujer de 32 años con PAP que informa "células glandulares atípicas de significado indeterminado" (AGC-NOS). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Colposcopía con biopsia y legrado endocervical
B) Biopsia endometrial únicamente
C) Conización cervical diagnóstica
D) Histerectomía total
E) Repetir PAP en 6 meses

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

AGC en PAP: mayor riesgo de adenocarcinoma cervical o endometrial. Conducta: colposcopía + biopsia dirigida + legrado endocervical (para mujeres >35 años o con riesgo). No es suficiente solo repetir el PAP. La conización se realiza si la colposcopía es inadecuada.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 179 3.01.4.007 · Papanicolau

Una paciente se realiza un PAP que es informado como satisfactorio, inflamatorio y con atipías glandulares. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Tratamiento con metronidazol
B) Tratamiento con estrógenos
C) Control con un PAP en un año
D) Repetir el PAP
E) Colposcopía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Por se atipías glandulares, lo más correcto es derivar a colposcopía y biopsia más curetaje endocervical.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 57 3.01.4.007 · Papanicolau

Una paciente, usuaria de DIU hace 7 años, se realiza Papanicolaou como chequeo médico, que muestra presencia de Actinomyces israeli, sin otras alteraciones. No refiere síntomas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar Papanicolaou en 1 año
B) Derivar a colposcopía
C) Realizar ecotomografía pelviana
D) Retirar el DIU
E) Iniciar antibióticos orales

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La presencia de actinomyces en paciente asintomática, no tiene consecuencias. Si tuviese síntomas (dolor, leucorrea, metrorragia), habría que retirar el DIU e indicar an- tibióticos (amoxicilina o penicilina).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 135 3.01.4.007 · Papanicolau

Una paciente de 57 años, menopáusica, sin antecedentes de importancia, se realiza un PAP, que es informado con presencia de células endometriales. La conducta más adecuada es:

A) Derivar a colposcopía y biopsia
B) Controlar con PAP en un año
C) Solicitar ecografía transvaginal
D) Tipificación de virus papiloma
E) Realizar cono cervical

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La presencia de células endometriales en el PAP se maneja igual que la presencia de menstruación. Por tanto, si es una mujer en edad fértil, se considera algo normal. En cambio, si es en una mujer postmenopáusica, se debe estudiar con una ecografía TV y, eventualmente, biopsiar el endometrio si tiene más de 5 mm o más de 8 mm, en caso de que use TRH.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 166 3.01.4.002 · Mamografía

Una paciente de 47 años acude a control ginecológico, observándose salida de secreción escasa por el pezón a la compresión, que ella no había notado previamente. Se solicita mamograFa, la que es informada como BI-RADS 2, y ecograFa mamaria, que muestra ectasia ductal retroareolar, BI-RADS 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar mamogra:a con compresión focal
B) Realizar control mamográfico en un año
C) Solicitar resonancia magné2ca nuclear de mama
D) Indicar mupirocina tópica
E) Resolver mediante resección quirúrgica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Birrads 0 (examen insuficiente) = Estudiar con otra imagen (generalmente ecografía). Birrads 1 (normal) = Control habitual en 1 a 2 años. Birrads 2 (alteración benigna) = Control habitual en 1 a 2 años. Birrads 3 (alteración probablemente benigna) = Control mamográfico en 6 meses (lo más importante), siendo aceptable complementar con ecografía mamaria ahora. Birrads 4 (lesión sospechosa) = Biopsia mamaria histológica (estereotáxica si tumor no palpable; con aguja gruesa si es palpable). Birrads 5 (lesión maligna) = Biopsia mamaria histológica + derivación a equipo de mama. BI-RADS 6 (cáncer confirmado por biopsia previa) = Tratamiento oncológico (cirugía ± radioterapia ± terapia sistémica según etapificación).

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 113 3.01.4.002 · Mamografía

Una paciente de 40 años se realiza una mamografía que reporta BIRADS 0 (insuficiente). Posteriormente, se realiza una ecografía mamaria con resultado BIRADS 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir la mamografía en 6 meses
B) Repetir la ecotomografía mamaria en 6 meses
C) Solicitar una mamografía con compresión lateralizada
D) Solicitar una resonancia magnética nuclear de mamas
E) Realizar biopsia estereotáxica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Manejo de Mamografías BIRADS 0: Las mamografías clasificadas como BIRADS 0 requieren estudios adicionales para su evaluación, siendo la ecografía mamaria la técnica de elección. En el caso de las ecografías mamarias BIRADS 2, la lesión es benigna. Sin embargo, se recomienda repetir la ecografía en 6 meses para confirmar su estabilidad. Un ejemplo de lesión BIRADS 2 en la ecografía es el fibroadenoma, que requiere de seguimiento en 6 meses.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 174 3.01.4.002 · Mamografía

redondeadas, agrupadas, catalogadas como mamografía Birrads ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa
B) Solicitar nueva mamografía en un año
C) Solicitar nueva mamografía en 6 meses
D) Solicitar ecografía mamaria
E) Realizar biopsia por punción, guiada por rayos X

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Birrads 3 = lesión de bajo riesgo de malignidad = control en 6 meses, pudiendo ser complementado con una ecografía. Recordemos también el Birrads 4 = lesión sospechosa = biopsia histológica (guiada por rayos X si tumor no palpable; o con aguja gruesa o mamótomo directo, si tumor palpable).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 16 3.01.4.002 · Mamografía

Una paciente de 45 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0, por presencia de opacidades nodulares bilaterales, bien delimitadas. La conducta más adecuada es:

A) Control mamográfico en 6 meses
B) Ecografía mamaria
C) Biopsia estereotáxica
D) Biopsia quirúrgica
E) Resonancia magnética nuclear de mama

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Birrads 0 = ecografía; Birrads 1 = control en 1 a 2 años; Birrads 2 = control en 1 a 2 años; Birrads 3 = mamografía en 6 meses (se puede complementar con ecografía); Birrads 4 = biopsia estereotáxica (si no es palpable) o con aguja gruesa (si palpable); Birrads 5 = biopsia quirúrgica.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 48 3.01.4.002 · Mamografía

Una mujer de 55 años se realiza una mamografía, como parte de un chequeo médico, que es informada como Birrads 4, por presencia de microcalcificaciones pleomorfas agrupadas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Ecografía mamaria
B) Biopsia estereotáxtica.
C) Resonancia magnética
D) Control mamográfico en 6 meses
E) Biopsia excisional

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Birrads 0 = ecografía; Birrads 1 = control en 1 a 2 años; Birrads 2 = control en 1 a 2 años; Birrads 3 = mamografía en 6 meses (se puede complementar con ecografía); Birrads 4 = biopsia estereotáxica (si no es palpable) o con aguja gruesa (si palpable); Birrads 5 = biopsia quirúrgica.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 147 3.01.4.002 · Mamografía

Una paciente de 46 años, sin antecedentes de importancia, se realiza una mamograFa que es informada como presencia de microcalcificaciones BI-RADS 0, por lo que se solicita una ecograFa mamaria, informada como BI-RADS 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar control mamográfico en 6 meses
B) Solicitar mamogra:a con magnificación
C) Solicitar mamogra:a con compresión focal
D) Realizar biopsia por punción con aguja fina
E) Realizar biopsia por punción con aguja gruesa

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy difícil y fuera de lo que debe manejar el médico general. Lo clásico es que una mamografía Birrads 0 (examen insuficiente) debe estudiarse con una nueva imagen, habitualmente la ecografía mamaria, que, en este caso resultó Birrads 2 (hallazgo benigno), por lo que se debe conGnuar con el screening habitual en una mujer sana. Sin embargo, las calcificaciones Birrads 0 son una excepción, ya que no se estudian con ecografía, sino con la “mamogra_a diagnós<ca” (se realiza en pacientes con síntomas mamarios, examen físico anormal o mamografía de screening alterada). Entre las proyecciones adicionales están: Compresión focal: úGl para evaluar masas o asimetrías. Magnificación: especialmente úGl para caracterizar microcalcificaciones.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 93 3.01.4.002 · Mamografía

Una paciente de 45 años, hipertensa, se detecta un nódulo mamario, por lo que se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 4. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar mamografía en un año
B) Solicitar ecografía mamaria
C) Solicitar resonancia nuclear magnética de mamas
D) Realizar biopsia por punción
E) Realizar mastectomía parcial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Birrads 0: Eco; 1 y 2: mamografía en un año; 3: mamografía en 6 meses; 4: biopsia histológica y 5: biopsia quirúrgica.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 49 3.01.4.002 · Mamografía

Una paciente de 41 años se realiza una mamografía, que es informada como Birrads 0, por presencia de opacidades fibronodulares bilaterales, bien delimitadas y sin calcificaciones. La conducta más adecuada es:

A) Control mamográfico en 6 meses
B) Ecotomografía mamaria
C) Biopsia guiada por rayos X
D) Mamografía en 1 año
E) Resonancia magnética nuclear de mama

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ecotomografía mamaria** (opción **B**). Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 45 3.01.1.026 · Prolapso genital

Una paciente de 58 años, multípara de cuatro, presenta sensación de peso vaginal, asociada a escapes de orina, al inicio del deseo miccional. Al examen físico presenta prolapso genital. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar oxibutinina oral
B) Realizar prueba Q-TIP
C) Realizar pelvic organ prolapse quantification (POP-Q)
D) Solicitar resonancia magnética pelviana
E) Realizar histerectomía

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El Prolapso se evalúa con el POP-Q: un examen físico formal, realizado por un ginecólogo, en el cual se mide el grado de prolapso de las distintas estructuras genitales.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 143 3.01.1.026 · Prolapso genital

Una mujer de 87 años, es institucionalizada por una demencia tipo Alzheimer. Al examen físico del ingreso se aprecia lo siguiente: INSERTAR FOTO ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cirugía de urgencia
B) Realizar PAP y colposcopía
C) Indicar pesario
D) Realizar biopsia
E) Cuidados paliativos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Era un prolapso uterino completo. Si fuera una mujer sana, se haría cirugía electi- va (no de urgencia), pero dado que era una paciente con alzheimer avanzado, se puede dejar pesario.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 159 3.01.5.012 · Prueba de trabajo de parto

Una paciente de 31 años, entra en trabajo de parto a las 37+6 semanas y al exami- narla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal myestra 5 cm de dilatación cervical, membranas íntegras y presentación cefálica, en espinas -1. El registro de la frecuencia cardiaca fetal está dentro de rangos normales. Se la evalúa a las 3 horas, manteniéndose sin cambios obstétricos. La conducta de elección es:

A) Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
B) Realizar fórceps
C) Realizar cesárea
D) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural
E) Administrar oxitocina endovenosa en goteo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tienen una fase activa lenta, que requiere de una prueba de trabajo de parto (romper membranas, anestesia y goteo oxitócico si las contracciones son menores a 3 en 10 min: no es el caso).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 109 3.01.5.012 · Prueba de trabajo de parto

Una paciente de 31 años, entra en trabajo de parto a las 38 semanas y al examinarla se constatan 3 contracciones uterinas en 10 minutos y su tacto vaginal muestra 5 cm de dilatación cervical, membranas íntegras y presentación cefálica, en espinas -1. El registro de la frecuencia cardiaca fetal está dentro de rangos normales. Se la evalúa a las 3 horas, manteniéndose sin cambios obstétricos. La conducta de elección es:

A) Mantener una conducta expectante por 1 hora y reevaluar
B) Administrar misoprostol
C) Realizar cesárea
D) Realizar rotura artificial de membranas y administrar anestesia epidural
E) Administrar oxitocina endovenosa en goteo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una fase activa lenta, que no ha progresado, por lo que se debe hacer una prueba de parto (RAM, anestesia y oxitocina para tener 3 a 5 CU/10 min: no necesario en este caso, ya que tiene 3 CU/10 min).

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 149 3.01.5.012 · Prueba de trabajo de parto

Una paciente de 23 años, está en trabajo de parto. Está con dilatación completa, buena dinámica uterina, membranas rotas y cabeza fetal 3 cm por sobre las espinas ciáticas. Desde hace 4 horas ha permanecido sin cambios. El monitoreo fetal es normal ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Dejar evolución espontánea
B) Administrar tocolisis con nifedipino
C) Realizar cesárea
D) Realizar con extracción con fórceps
E) Realizar extracción con vaccum de la cabeza fetal Respuesta: Tiene una prueba de parto fracasada 2 horas sin avance, a pesar de buena dinámica y membranas rotas , por lo que se debe hacer una cesárea por desproporción cefalopélvica.

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Realizar cesárea** (opción **C**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 78 3.01.3.010 · Prevención de enfermedades

Una paciente de 22 años consulta por la vacuna contra el virus papiloma humano. Inició su actividad sexual hace 4 años y cuenta con un PAP normal, hace 1 año. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir el PAP
B) Vacunar con 2 dosis
C) Vacunar con 3 dosis
D) Realizar tipificación del virus papiloma humano
E) Derivar a colposcopía y eventual biopsia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vacuna está pensada para niñas y niños que no han iniciado su actividad sexual (además que no ha demostrado ser mejor que el PAP). Por eso, el PAP de control es lo más importante. Eso sí, en la vida real, si es virgen al virus, igual serviría la vacuna.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 83 3.01.5.011 · Perfil biofisico fetal

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 40 semanas, consulta por ausencia de movimientos fetales, por lo que se realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con oligoamnios. La conducta más adecuada es:

A) Dejar a evolución espontánea
B) Interrumpir ahora por cesárea
C) Inducir el parto en este momento
D) Realizar cesárea al momento del trabajo de parto
E) Inducir el parto a las 41 semanas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El oligoamnio se maneja según la causa (no aparecía bucar la causa). El idiopático puede manejarse como un embarazo normal y no contraindica el parto vaginal. Se suele interrumpir al llegar a término y máximo a las 40 semanas, por el riesgo de óbito fetal.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 24 3.01.5.011 · Perfil biofisico fetal

Embarazo a término, 39 semanas con PBF 6/8 con LA 0/2 conducta

A) Inducir b. Cesárea
C) Eco doppler seriado Según entiendo, era un OHA idiopático, lo que no es malo, pero hay que hacerle eco doppler para ver si hay insuficiencia placentaria, era muy similar a una de un ensayo.. si pero como estaba de termino mejor la interrumpes..., se suelen interrumpir a las 40, tenia 37
C) Interrupción del embarazo
D) Maduración pulmonar y observación
E) Cesárea de urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Inducir b. Cesárea** (opción **A**). La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 54 3.01.5.011 · Perfil biofisico fetal

Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 40 semanas, consulta por ausencia de movimientos fetales, por lo que se realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con presencia de oligoamnios. La conducta más adecuada es:

A) Dejar a evolución espontánea
B) Interrumpir ahora por cesárea
C) Inducir el parto en este momento
D) Realizar cesárea al momento del trabajo de parto
E) Inducir el parto a las 41 semanas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un perfil 8/10, es decir, tranquilizador. Sin embargo, además tiene un OHA. Se debe estudiar el OHA con un doppler fetal, en busca de insuficiencia placentaria. Sin embargo, la mayoría de los OHA sin otras patologías o alteraciones suelen ser idiopáticos. En este caso se interrumpen a las 40 semanas, sin contraindicar el parto vaginal.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 156 3.01.5.011 · Perfil biofisico fetal

Una paciente de 31 años, con embarazo de 40 semanas, acude al servicio de urgencia por ausencia de percepción de movimientos fetales. Se realiza un perfil biofísico, que resulta 8/10, con oligoamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Interrumpir a las 41 semanas
B) Interrumpir a las 42 semanas
C) Interrumpir el embarazo ahora
D) Repetir el perfil biofísico en 48 horas
E) Esperar el inicio del trabajo de parto

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta discutible y con más de una opción aceptable. Que tenga un PBF 8/10 es tranquilizador y muestra que la única razón por la que ha bajado es por el OHA. Sin embargo, en los embarazos de término (mayores a 37 semanas) con ILA menor a 5 (probablemente sea el caso, por tener 0/2 en el PBF), se recomienda la interrupción del embarazo. Si tuviera un ILA mayor a 5, se podría mantener en control cada uno a dos días.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 90 3.01.3.003 · Determinación de edad gest

Una paciente con antecedente de reglas irregulares, que ocurren cada 45 a 60 días, se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Tiene una FUR segura hace 6 semanas y se solicitó HCG plasmática de 25.000 UI/L, que corresponde a una edad gestacional entre 6 y 7 semanas. ¿Cuál es la forma ideal para determinar la edad gestacional en esta paciente?

A) FUR segura
B) Medición de la altura uterina
C) Determinación de HCG plasmática en 48 horas
D) Medición ecográfica del saco gestacional
E) Medición ecográfica de la longitud cráneo-nalgas Fin de la primera parte

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La FUR no es confiable (por ser irregular) por lo que no sirve. Aún así, la ecografía es el mejor indicador y a esa edad gestacional manda la longitud céfalo-nalgas. SEGUNDA PARTE

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 148 3.01.2.002 · Absceso glándula de Bartol

Mujer de 20 años tras parto vaginal con episiotomía presenta aumento de volumen doloroso, azulado y fluctuante en el labio mayor derecho de 48 horas de evolución. Sin fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?

A) Hematoma vulvar: compresas frías y analgesia si no aumenta
B) Absceso vulvar: drenaje + antibióticos
C) Quiste de Bartolino: observación ambulatoria
D) Linfocele: punción aspirativa
E) Tromboflebitis pélvica: anticoagulación

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Absceso vulvar/hematoma infectado post-parto: aumento de volumen azulado + fluctuante + doloroso a las 48h del parto = hematoma infectado o absceso. Requiere drenaje quirúrgico + antibióticos (amoxicilina-clavulánico). El hematoma no infectado (<24h, sin fiebre) se maneja con compresas frías.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 141 3.01.2.002 · Absceso glándula de Bartol

Una mujer de 41 años consulta por dolor en la zona vulvar derecha, de dos días de evolución. Al examen Fsico se observa aumento de volumen eritematoso y muy doloroso a la palpación, de ubicación posterolateral en relación al labio mayor derecho. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Forunculosis vulvar
B) Celuli2s vulvar
C) Absceso de Bartolino
D) Absceso perianal
E) Quiste epidermoide vulvar infectado

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **C** (Absceso de Bartolino). Es un absceso de Bartholino clásico.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 119 3.01.2.002 · Absceso glándula de Bartol

Una paciente de 32 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona vulvar derecha. Al examen Fsico se observa aumento de volumen de 3 cm de diámetro, eritematoso y doloroso a la palpación, en relación con el tercio posterior del labio mayor derecho. Refiere haber tenido un episodio previo que requirió drenaje quirúrgico. Además del tratamiento quirúrgico para la lesión actual, ¿qué an8bió8co debe administrarse?

A) Metronidazol oral
B) Ciprofloxacino oral
C) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
D) Azitromicina oral
E) Trimetoprim-sulfametoxazol

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Aunque no queda clara la uGlidad de los antibióticos en el absceso de Bartholino, los esquemas más uGlizados son 1. amoxicilina + ácido calvulánico o 2. Cefadroxilo + metronidazol. Suelen indicarse en los casos con infección severa y en las recurrencias. El tratamiento quirúrgico está indicado en los abscesos menores de 3 cm, con incisión simple. En cambio, en las recurrencias o lesiones de más de 3 cm, se tratan con el catéter de Word (si está disponible es de elección) o marsupialización (Bartholinocistoneostomía).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 168 3.01.2.002 · Absceso glándula de Bartol

Una paciente de 30 años, con actividad sexual, consulta por dolor vulvar y sensación febril. Al examen físico se aprecia aumento de volumen eritematoso, de 6 cm de diámetro, doloroso, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. La conducta terapéutica más adecuada es:

A) Cistectomía de Bartholino
B) Drenaje por punción
C) Drenaje quirúrgico simple
D) Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo
E) Bartholinocistostomía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta discutible, pero desde hace algunos años se recomienda de entrada la marsupialización del absceso de Bartholino (Bartholinocistostomía) por tener menos recurrencia y ser técnicamente muy simple (yo la tuve mala, porque marué drenaje simple).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 111 3.01.2.002 · Absceso glándula de Bartol

Una paciente de 35 años, con antecedente de 3 abscesos de Bartholino, que han requerido drenaje quirúrgico, consulta por dolor en la zona vulvar de dos días de evolución. Al examen ginecológico, se observa aumento de volumen de 3 cm, en relación al labio menor derecho, a tensión, que es doloroso a la palpación y no presenta signos inflamatorios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Bartholinocistoneostomía
B) Evacuación por punción
C) Vaciamiento por incisión
D) Antibióticos orales
E) Baños de asiento y analgésicos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Bartholinocistoneostomía** (opción **A**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 52 3.01.2.002 · Absceso glándula de Bartol

Mujer con múltiples abscesos de Bartolino tratados con punción, ahora con aumento de volumen doloroso sin eritema ni fiebre. ¿Cuál es la conducta?

A) Punción y drenaje nuevamente
B) Antibioterapia oral por 10 días
C) Bartholinoneocistostomía (marsupialización)
D) Exéresis de la glándula
E) Antibiótico endovenoso hospitalizada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Bartholinoneocistostomía (marsupialización)** (opción **C**). Bartholinoneocistostomía (marsupialización). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 42 · 3.01.2.002 · Absceso glándula de Bartol

Una paciente de 30 años, con antecedente de abscesos a repetición de la glándula de Bartholino derecha, que han sido drenados mediante punción o incisión, consulta nuevamente por dolor vulvar. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, de 5 cm de diámetro, doloroso a la palpación, en relación a la zona posterior del labio mayor derecho. La conducta terapéutica más adecuada es:

A) Cistectomía de Bartholino
B) Drenaje por punción
C) Drenaje quirúrgico simple
D) Iniciar antibióticos orales y esperar el drenaje espontáneo
E) Bartholinoneocistostomía

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La marsupialización o Bartholinoneocistostomía es el tratamiento de los quistes de Bartholino con complicaciones recidivantes. Si solo se complica una vez, se puede drenar quirúrgicamente o por punción, si es pequeño. Si se absceda, además, se deben dejar antibióticos de amplio espectro, con cobertura de ETS.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 74 · 3.01.3.009 · Prevención de enfermedad h

Una paciente de 23 años, primigesta, cursando embarazo de 13 semanas, se realiza determinación de grupo sanguíneo, que es informada como AB, Rh(-), Du (+). ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Solicitar doppler de arteria cerebral media fetal
B) Solicitar Coombs indirecto a las 18 semanas
C) Administrar Rhogam a las 28 semanas
D) Determinar grupo y Rh del padre
E) Mantener control habitual del embarazo

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta difícil, pero que sea Du(+) implica que realmente no debe manejarse como Rh(-), sino como Rh(+), es decir, como un embarazo común. Actualmente se recomienda complementar con el Du, ya que muchas embarazadas Rh(-) en realidad no tenían riesgo alguno y eran sometidas a múltiples Coombs y Rogham, sin necesidad real.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 146 · 3.01.4.001 · Histerosalpingografía

Una paciente de 38 años consulta porque lleva dos años intentando embarazarse, junto a su pareja. Sus reglas son regulares, su examen físico es normal y cuentan con múltiples exámenes hormonales que dan cuenta que tiene ciclos ovulatorios. Su pareja, de 28 años se realizó un espermiograma, que resultó normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Histeroscopía
B) Laparoscopía
C) Histerosalpingografía
D) Niveles plasmáticos de hormona anti-mülleriana
E) Seguimiento folicular ecográfico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las causas más frecuentes de infertilidad son 1. Masculina (40%), anovulación (30), tuboperitoneal y endometriosis. Por tener ciclos regulares, no tiene anovulación ni hipogonadismo. En todo caso, con los exámenes que ya se realizó se confirmó. Además, por tener un espermiograma normal, no parece causa masculina. La siguiente causa a descartar es la tuboperitoneal, que se estudia con histerosalpingografía (se asocia a ETS y PIP).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 165 · 3.01.3.005 · Manejo de la salud de la m

¿Qué antecedente es indicación del uso de estrógenos orales solos, en la terapia de reemplazo hormonal?

A) Cáncer de mama
B) Dislipidemia
C) Histerectomía total
D) Osteoporosis
E) Menopausia precoz

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La TRH en mujeres con útero es con estrógeno y progestágeno, pero el progestágeno tiene como única utilidad evitar el cáncer de endometrio que se generaría por la constante estimulación estrogénica, sin la contraposición progestágena. En cambio, si no hay útero, solo se indican los estrógenos, evitando los efectos adversos del progestágeno.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 16 · 3.01.5.005 · Evaluación anteparto

Una paciente de 28 años, cursando su segundo embarazo de 35 semanas + 6 días, consulta por un cuadro de astenia, malestar general y aumento de volumen en las extremidades inferiores. Además, hace 24 horas ha notado disminución de los movimientos fetales. Sus antecedentes obstétricos solo muestran una cesárea previa por presentación podálica. Se solicita un registro basal no estresante, que resulta no reactivo. Su examen físico muestra edema de las extremidades inferiores, PA: 149/96x', FC: 80x', altura uterina de 31 cm y su tacto vaginal muestra cuello uterino sin dilatación y con índice de Bishop de 3 puntos. Se solicita un perfil biofísico, que muestra tono flexor y movimientos fetales y respiratorios presentes, con líquido amniótico con un bolsillo único menor a 1 cm. Se repite el registro basal no estresante, que vuelve a resultar no reactivo. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar el test de tolerancia a las contracciones
B) Solicitar Doppler fetal
C) Repetir el perfil biofísico
D) Inducir el parto con misoprostol
E) Realizar cesárea de urgencia

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Solicitar Doppler fetal** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 64 · 3.01.2.020 · Mastitis abscedada

Una paciente de 32 años, puérpera de parto vaginal eutócico de 8 días de evolución, consulta por dolor mamario derecho, mayor durante la lactancia. Al examen físico tiene T°: 38,5°C, FC: 100x', PA: 120/78 mmHg. Ambas mamas se observan eritematosas, con grietas visibles en el pezón y, en el lado derecho, se palpa aumento de volumen doloroso y fluctuante a la palpación, de 6 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local y eritema. El examen ginecológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibióticos endovenosos más drenaje quirúrgico o por punción guiado por ecografía
B) Drenaje por punción
C) Suspender la lactancia materna
D) Frío local y paracetamol
E) Amoxicilina más ácido clavulánico vía oral

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Suspender la lactancia materna** (opción **C**). Manejo según Fase al Llegar De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 51 3.01.2.020 · Mastitis abscedada

Puérpera con fiebre, eritema mamario, calor local y aumento de volumen fluctuante. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Antibiótico oral y continuar lactancia
B) Antibiótico endovenoso y suspender lactancia
C) Antiinflamatorios y masaje local
D) Antibiótico y bromocriptina para suspender lactancia
E) Drenaje quirúrgico y antibióticos

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Drenaje quirúrgico y antibióticos** (opción **E**). Drenaje quirúrgico y antibióticos. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 73 3.01.2.020 · Mastitis abscedada

Paciente puérpera con mama eritematosa con calor local y aumento de volumen fluctuante de 7 cm, además de iniciar atb, se debe; a. Drenaje de absceso mamario,

B) Suspender LM
B) Psoriasis
C) Dermatitis atópica
D) Dermatitis de contacto
E) Liquen plano

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Suspender LM, Psoriasis) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 38 3.01.5.013 · Taponaje vaginal

Ca cu con sangrado activo q no responde a ac tranexámico: a. Taponamiento vaginal (REPETIDA DE AÑO ANTERIOR)

B) Ligar arterias cervicales
B) Ninguna de las anteriores es correcta
C) Todas las anteriores son correctas
D) No se dispone de información suficiente
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ligar arterias cervicales, Ninguna de las anteriores es correcta) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 118 3.01.3.002 · Derechos y aspectos legale

Paciente de 22 años con embarazo de 18 semanas acude a urgencias solicitando interrupción voluntaria del embarazo. No presenta ninguna de las tres causales legales vigentes en Chile. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Informar que la interrupción no procede legalmente y derivar a consejería
B) Realizar la interrupción por solicitud de la paciente
C) Derivar de urgencia a matrona
D) Hospitalizar para observación
E) Referir a comité de ética del hospital

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En Chile (Ley 21.030), la IVE es legal solo en 3 causales: riesgo vital, inviabilidad fetal y violación. Sin causales presentes, no procede la interrupción. El médico debe informar, orientar y derivar a apoyo psicosocial.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 87 3.01.3.002 · Derechos y aspectos legale

Huevo anembrionado aborto, si se le da licencia remunerada o no al papá(? Y cuantos dias: a. Reposo por 10 días continuos remunerado (ley Dominga permite 10 días hábiles continuos!!)

B) Permiso 7 días hábiles remunerado
C) No tiene permiso porque no se demuestra embrión
D) Permiso de 5 días solo si hay unión civil (no recuerdo exactamente)
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Permiso 7 días hábiles remunerado). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (No tiene permiso porque no se demuestra embri, Permiso de 5 días solo si hay unión civil (no) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 44 3.01.1.030 · Cáncer de mama

Una paciente de 58 años consulta por lesiones pruriginosas con descamación en el pezón y la areola derecha de 6 meses de evolución, sin respuesta al tratamiento con an8micó8cos tópicos. Al examen Fsico se observa lo siguiente: ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Cáncer inflamatorio de mama
B) Enfermedad de Paget
C) Derma22s de contacto
D) Psoriasis del pezón
E) Mas22s

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una enfermedad de Paget clásica, que es una Gpo de cáncer de mama, en específico un carcinoma in situ, que se exGende por el pezón y la areola. Es característico el engrosamiento de la piel, con descamación y presencia de costras. Se debe buscar la presencia de otro cáncer de mama (mamografías, etc.). Se diagnostica con biopsia. El tratamiento es resorte del especialista. Fuente imagen: hxps://www.revistamsp.com.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 95 · 3.01.2.018 · Pelviperitonitis

Una paciente de 25 años consulta en el servicio de urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, que ha aumentado de intensidad. Es sexualmente ac8va y u8liza disposi8vo intrauterino 8po T de cobre como método an8concep8vo. Refiere que el dolor es más intenso en el abdomen bajo, mayor al lado derecho. En su examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 108 por minuto y presión arterial 110/70 mmHg, examen abdominal con dolor a la palpación abdominal baja y signo de Blumberg esbozado a derecha. La especuloscopía muestra cuello uterino con secreción purulenta y el tacto vaginal demuestra dolor a la presión cervical y a la palpación de ambos anexos, mayor a derecha. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Embarazo ectópico
B) Aborto sép2co
C) Torsión ovárica
D) Pelviperitoni2s
E) Apendici2s aguda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un proceso inflamatorio pélvico (PIP) clásico, también llamado enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o pelviperitoniGs cuando hay signos de compromiso peritoneal. Se debe estudiar con una ecografía TV para descartar abscesos tubo ováricos. Además, se debe tratar con antibióticos de amplio espectro. No es necesario reGrar el DIU, a menos que no responda en 48 horas de antibioterapia o que además del PIP se confirme la presencia de Ac9nomyces.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 172 · 3.01.3.013 · Screening ginecológico: Pa

Una mujer de 34 años, con vacunación completa contra el virus papiloma humano, se realiza un PAP, que es informado como muestra sa8sfactoria sin presencia de a8pías celulares, y una prueba de detección de virus papiloma humano que es informada como posi8va para VPH de alto riesgo, sero8po 56. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar refuerzo de la vacunación contra el VPH
B) Realizar control de PAP en un año
C) Realizar colposcopía
D) Repe2r el PAP en este momento
E) Realizar conización cervical

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

A diferencia de los seroGpos 16 y 18 (que suelen derivarse a colposcopía de manera inmediata porque son los más agresivos), los otros genoGpos de alto riesgo (como el 31, 33, 35, 45, 56, etc.) con un PAP normal se manejan bajo una conducta de observación y control. De todos modos es una pregunta muy difícil, ya que lo clásicamente enseñado es que las indicaciones de colposcopía son: 1. PAP escamoso de alto grado. 2. VPH de alto grado (únicamente 16 y 18). 3. PAP de bajo grado más VPH de bajo grado. 4. PAP con aGpias glandulares (cualquier grado). 5. Lesión cervical visible en la especuloscopía.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 41 · 3.01.4.006 · Ecotomografía mamaria

Mujer de 45 años con ecografía mamaria que informa BIRADS 0. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Completar estudio con mamografía bilateral
B) Biopsia core guiada por ecografía
C) Control en 6 meses
D) Alta y control anual
E) RMN mamaria de urgencia

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

BIRADS 0 = evaluación incompleta, se requieren imágenes adicionales para concluir. La ecografía BIRADS 0 se completa con mamografía u otras proyecciones. No es resultado final.

SALUD PÚBLICA, BIOÉTICA & GES

Módulo 4: Salud Pública y Gestión · Colección Tomo 21

175 PREGUNTAS REALES CONVOCATORIAS 2013 - 2025

MATRIZ DE FRECUENCIA PERFIL V3 & ENLACE A MANUALES DE ESTUDIO AEE

43 CÓDIGOS EVALUADOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.07.1.001	Caídas	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	1 Q	Tomo 10 · 10.23 (Pág. 85)
1.07.1.003	Demencia	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · C.3 (Pág. 10)
1.07.1.007	Escaras o úlceras por presión	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 01 · C.7 (Pág. 18)
1.07.1.008	Fragilidad	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 10 · 10.22 (Pág. 83)
1.07.1.012	Incontinencia urinaria	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	2 Q	Manual General · Pág. 6
1.07.2.004	Agitación y agresividad	Dx: **Sospecha** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 01 · C.14 (Pág. 32)
1.07.2.005	Síndrome confusional agudo / delirium	Dx: **Específico** · Tx: **Completo**	13 Q	Tomo 10 · 10.21 (Pág. 79)
1.07.3.003	Manejo, cuidado y acompañamiento de final de vida	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Manual General · Pág. 6
1.07.3.005	Envejecimiento saludable y promoción del autocuidado	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Manual General · Pág. 6
1.07.3.007	Manejo de fármacos en la persona mayor	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 10 · 10.24 (Pág. 87)
1.07.5.002	Valoración cognitiva	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Manual General · Pág. 6
7.01.3.004	Niveles de prevención	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.006	Determinantes del nivel de salud	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.007	Demografía y salud pública	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	9 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.009	Indicadores de nivel de salud: cálculo e interpretación	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	16 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.010	Etapas del diagnóstico de situación de salud	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.014	Epidemiología descriptiva	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.015	Usos de la epidemiología en el control de enfermedades	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.016	Vigilancia epidemiológica y estudio de brotes	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	12 Q	Tomo 21 · 21.4 (Pág. 15)
7.01.3.018	Epidemiología analítica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA OFICIAL	NIVEL LEGAL EXIGIDO	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
7.01.3.019	Medidas de asociación e impacto	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	8 Q	Tomo 21 · 21.7 (Pág. 28)
7.01.3.020	Diseños de investigación epidemiológica	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · 21.6 (Pág. 24)
7.01.3.022	Estudios de casos y controles	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.023	Estudios de cohortes	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.024	Estudios experimentales y cuasiexperimentales	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.025	Concepto de estudios ecológicos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.026	Causalidad y sesgos	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	7 Q	Tomo 21 · 21.9 (Pág. 36)
7.01.3.028	Pruebas de screening (tamizaje) y diagnósticas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	6 Q	Tomo 21 · 21.8 (Pág. 32)
7.01.3.031	Estrategias de control de enfermedades infecciosas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.032	Estrategias de control de enfermedades crónicas prioritarias (cáncer, cardiovasculares)	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.036	Organización actual del sistema de salud chileno	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 21 · 21.1 (Pág. 5)
7.01.3.038	Definición, estructura y funciones de los subsistemas en Chile	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.039	Concepto y descripción de la red asistencial chilena	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.040	Beneficios de la seguridad social y rol del médico en su acceso	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	4 Q	Tomo 21 · 21.2 (Pág. 9)
7.01.3.042	Planificación y programación en salud	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	2 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.045	Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.046	Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.047	Auditoría y acreditación	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	5 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.049	Financiamiento del sector salud	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.051	Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · 21.13 (Pág. 49)
7.01.3.052	Ejercicio profesional: marcos ético, legal y gremial	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · 21.11 (Pág. 43)
7.01.3.054	Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	3 Q	Tomo 21 · 21.14 (Pág. 53)
7.01.3.056	Conocimiento de los derechos y deberes del paciente	Dx: **Específico** · Tx: **Inicial**	1 Q	Tomo 21 · 21.12 (Pág. 47)

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 146 7.01.3.024 · Estudios experimentales y

La característica de los estudios experimentales, que los diferencian de los demás tipos de estudios es que:

A) La selección es aleatorizada
B) Siempre utiliza triple ciego
C) El investigador controla algunas variables
D) El investigador selecciona los grupos de intervención
E) Utiliza test de hipótesis

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los estudios experimentales (ej. ensayo clínico y estudio de intervención comunitaria) se caracterizan porque existe una intervención, que es lo mismo que decir que se controlan algunas variables independientes. Esto los diferencia de los estudios observacionales. Los test de hipótesis se usan en los estudios analíticos, en contraposición a los estudios descriptivos (es una clasificación distinta y hay estudios observacionales tanto analíticos como descriptivos, por ejemplo). La selección aleatorizada es algo recomendable para evitar el sesgo de selección, pero un estudio experimental no necesariamente funciona así. Lo mismo ocurre con el ciego, ya sea simple (del evaluado), doble (también del evaluador) o triple (además, del analista de datos), que sirve para evitar sesgos de medición, pero no todos los estudios experimentales los usan.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 5 7.01.3.024 · Estudios experimentales y

Se desea evaluar la efectividad de un nuevo antihipertensivo de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para esto, ¿Qué tipo de estudio escogería?

A) Caso control
B) Meta-análisis
C) Cohorte
D) Corte transversal
E) Estudio clínico randomizado

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Por ser un fármaco nuevo es imposible tener estudios para hacer un meta-análisis. Así que lo mejor es el ensayo clínico. Eso sí, lo que se mide es eficacia y no efectividad, pero de todos modos es la respuesta más correcta.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 124 7.01.3.024 · Estudios experimentales y

Un estudio determina que se deben tratar a 20 pacientes con una intervención, para evitar que uno fallezca. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

A) De incidencia
B) Casos y controles
C) Cohortes anidada
D) Ensayo clínico
E) De prevalencia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Se calculó el NNT, que en este caso es de 20. Sin embargo, lo preguntado es qué tipo de estudio es y por tratarse de una "intervención", se asume que es un estudio experimental, es decir, un ensayo clínico.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 14 1.07.3.003 · Manejo, cuidado y acompaña

Un paciente de 80 años en cuidados paliativos por cáncer de glotis, presenta desde hace un mes tos y regurgitación alimenticia, no ha presentado neumonías aspirativas ni otras complicaciones. ¿Cuál es la vía de administración de medicamentos más adecuada para este paciente?

A) Rectal
B) Sublingual
C) Intramuscular
D) Endovenosa
E) Subcutánea

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy capciosa, ya que depende del medicamento, pero en general, los cuidados paliativos reciben fármacos por vía oral y si no se puede, por vía subcutánea (ej. morfina subcutánea), dado que la dosis es más constante que en rectal y soblingual y es menos dolorosa que la intramuscular. Sigue siendo una mala pregunta.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 143 7.01.3.004 · Niveles de prevención

¿A qué concepto corresponde la siguiente definición: “Conjunto de medidas des8nadas a evitar que una enfermedad ocurra, actuando antes de que exista la enfermedad o el daño causado por esta”?

A) Prevención primaria
B) Prevención secundaria
C) Prevención terciaria
D) Prevención cuaternaria
E) Promoción de la salud

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Prevención primaria actúa antes de que exista la enfermedad (ej. vacunas con papiloma). Prevención secundaria actúa cuando ya existe la enfermedad, pero todavía no hay síntomas, permiGendo un diagnóstico oportuno (ej. PAP). Prevención terciaria actúa cuando la enfermedad ya Gene síntomas, para recuperar la salud y evitar complicaciones y recidivas (ej. histerectomía radical). Prevención cuaternaria enfrenta los síntomas, en ausencia de una patología orgánica (ej. psicoterapia de trastorno somatomorfo). Promoción de la salud consiste en enseñar hábitos de vida saludables, por lo que se enmarca dentro de la prevención primaria, pero su definición es específica.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 69 7.01.3.004 · Niveles de prevención

¿A qué tipo de medidas corresponde la instalación de las salas IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) y salas ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto), durante las campañas de invierno, por parte del Ministerio de Salud?

A) Prevención primaria
B) Prevención secundaria
C) Prevención terciaria
D) Promoción de la salud
E) Prevención específica

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La enfermedad ya está presente y los pacientes ya tienen síntomas, así que es una medida de prevención terciaria. La primaria es antes de la enfermedad. La secundaria es antes de los síntomas.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 170 · 7.01.3.004 · Niveles de prevención

Desde el año 2005 existe la ley que obliga a los automovilistas a utilizar el cinturón de seguridad con el objetivo de disminuir traumatismos asociados a accidentes. Con respecto a esta ley, en términos de prevención, corresponde a:

A) Prevención primaria
B) Promoción de salud
C) Prevención secundaria
D) Prevención tercearia
E) Control sanitario

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Prevención primaria** (opción **A**). Previene traumatismos.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 21 · 7.01.3.004 · Niveles de prevención

Acude a control una paciente de 26 años, trae el resultado de su papanicolau que es informado como "muestra satisfactoria, sin atipías". ¿A qué tipo de prevención corresponde este examen?

A) Prevención específica
B) Promoción de salud
C) Prevención secundaria
D) Prevención tercearia
E) Prevención primaria

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El PAP hace Dg precoz, para tratamiento oportuno. Por tanto es secundaria. La vacunación contra el VPH sí es primaria.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 167 · 7.01.3.004 · Niveles de prevención

¿A que tipo de medida corresponde la vacunación contra una enfermedad, en la historia natural de una enfermedad?

A) Promoción de salud
B) Protección específica
C) Erradicación de la enfermedad
D) Diagnóstico oportuno
E) Tratamiento precoz

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Protección específica). Es una medida clásica de prevención primaria, de tipo prevención específica.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 72 · 7.01.3.004 · Niveles de prevención

¿A qué tipo de medida corresponde el screening de fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile?

A) Promoción de la salud
B) Protección de la salud
C) Prevención primaria
D) Prevención secundaria
E) Prevención terciaria

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Prevención secundaria). Las pruebas de screening son una clásica medida de prevención secundaria.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 176 · 7.01.3.004 · Niveles de prevención

¿A qué tipo de medida corresponde el tamizaje de TSH y fenilcetonuria que se hace a todos los recién nacidos en Chile?

A) Promoción de la salud
B) Prevención específica
C) Prevención primaria
D) Prevención secundaria
E) Prevención terciaria

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las medidas de tamizaje son prevención secundaria (detectan la enfermedad que ya existe, antes de los síntomas).

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 11 · 7.01.3.004 · Niveles de prevención

¿Cuál de las siguientes medidas es más eficaz, en el mediano plazo, para disminuir la cantidad de pacientes diabéticos que progresan a necesitar hemodiálisis?

A) Screening de glicemia en población de riesgo de diabetes
B) Screening de glicemia en población adulta
C) Tratamiento eficaz en pacientes diabéticos diagnosticados
D) Prevención de factores de riesgo cardiovascular en la población adulta
E) Prevención de obesidad en la población de riesgo de diabetes

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy rara y muy mala, pero la única respuesta aceptable es la C, ya que es la única medida de prevención terciaria y es la forma en que se plantea la pregunta (evitar complicaciones). La A y B son prevención secundaria. La D y E son prevención primaria.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 127 · 7.01.3.004 · Niveles de prevención

Paciente EPOC TBQ activo, con disnea, se va a hacer un EMPA y la enfermera le hace consejería para que deje de fumar para que mejore la disnea ¿Que tipo de prevención es?

A) Prevención 1°
B) Prevención 2° c. Prevención 3°
D) Promoción de la salud (esta Era prevencion terciaria) segun yo era promocion porque igual depende del caballero si deja de fumar o no entonces no es un acto preventivo perse - Eso mismo e. Prevención 4 Pero da la razon de consejeria, es para mejorar disnea de enfermedad que ya tiene. Era prevencion terciaria porque el paciente ya estaba sintomatico, en fase de rehab.
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Prevención 1°). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Prevención 2° c. Prevención 3°, Promoción de la salud (esta Era prevencion te) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 40 · 7.01.3.023 · Estudios de cohortes

Se realiza un estudio donde se comparan dos grupos de personas mayores de 60 años, uno de ellos corresponde a hipertensos y el otro de características similares pero sin hipertensos, se siguen por 5 años y se evalúa la aparición de infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Este enunciado corresponde a un estudio de:

A) Corte transversal
B) Caso control
C) Estudio clínico randomizado
D) Cohorte
E) Ensayo de campo

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Cohorte** (opción **D**). Se siguen al futuro dos grupos: expuestos y no expuestos a un FR (HTA en este caso). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 49 · 7.01.3.023 · Estudios de cohortes

Se hace estudio de FRCV y alimentación en estudiantes medicina en el año 2000. En el 2022 se reevalúa a los mismos para ver aparición de enfermedades cv. Qué tipo de estudio es: a. Cohortes prospectivo.

B) Cohorte retrospectivo
C) Caso control
D) Transversal
D) Hemograma y VHS
E) Ecografía

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Cohorte retrospectivo, Caso control) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 13 · 7.01.3.023 · Estudios de cohortes

En un estudio de cohortes sobre el tabaco y cáncer de pulmón, luego de 20 años, se determinad que 65 de 2.000 pacientes fumadores enfermaron de cáncer. ¿Qué medida es posible calcular con esta información?

A) Incidencia acumulada en los pacientes fumadores
B) Prevalencia en los pacientes fumadores
C) Riesgo relativo
D) Odds ratio
E) Tasa de ataque en los pacientes fumadores

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Solo se puede calcular la incidencia con esa información (incidencia a 20 años = 65 / 2.000 = 3,25%). Si se tuvieran los datos en los no fumadores, además podría calcularse el riesgo relativo.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 68 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Un paciente de 80 años, autovalente, inicia cuadro de compromiso del estado general, tos y expectoración mucopurulenta, se realiza radiografía de tórax en donde se comprueba diagnóstico de neumonía basal derecha por lo que se hospitaliza para el tratamiento. Durante la hospitalización en la noche el paciente se agita, se saca sonda foley y vías venosas, durante la mañana está tranquilo. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome confusional agudo
B) Delirio
C) Alzheimer
D) Meningitis bacteriana
E) Demencia frontotemporal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

De libro. También se llama delirium. Si bien delirio es la traducción al español de la palabra en latín "delirium", en Chile se suele usar "delirio" para la pérdida de juicio de realidad de los pacientes psicóticos (delirio paranoide, megalomaniaco, erotomaniaco, etc) y delirium para el síndrome confusional agudo.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 172 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Adulto mayor hospitalizado por infección, comienza con desorientación temporoespacial, inatención e ideas deliriosas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Demencia de inicio agudo
B) Trastorno psicótico breve
C) Delirium
D) Encefalopatía hepática
E) Trastorno disociativo agudo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Delirium** (opción **C**). Delirium. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 139 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Un paciente de 84 años presenta desgarro mucopurulento, desde hace 4 días, por lo que se hospitaliza y se inicia tratamiento antibiótico. Evoluciona con dificultades para reconocer a sus hijos y esposa, a quienes confunde con su mamá y hermanos ya fallecidos. Se molesta cuando lo contrarían e incluso llegó a agredir físicamente a uno de sus hijos. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Trastorno delirante
C) Depresión psicótica
D) Esquizofrenia
E) Delírium

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un delirium o síndrome confusional agudo clásico (desorientación y compromiso de conciencia de inicio agudo), patología frecuente en el adulto mayor y que, en este caso, es secundario a la infección bacteriana. Las alucinaciones y el delirio son frecuentes y no por ello se trata de una esquizofrenia (cuadro crónico, que inicia en la adolescencia) o un trastorno delirante (delirio sistematizado de más de un mes, que, si dura más de 3 meses, se llama trastorno delirante crónico).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 8 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Mujer de 81 años, hospitalizada por neumonía, presenta agitación psicomotora en las noches, agrediendo al personal hospitalario y no reconoce a sus familiares. En el día, por el contrario, está en buenas condiciones, tranquila y no recuerda lo sucedido. ¿Cuál es el diagnostico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Accidente vascular encefálico
C) Delirium
D) Demencia
E) Trastorno delirante

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un delirium clásico (alteración de la atención, compromiso de conciencia de inicio agudo, desorientación y agitación; suele tener un curso fluctuante y empeorar al atardecer y en la noche). También se llama síndrome confusional agudo.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 138 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Una paciente de 78 años, diabética e hipertensa, es hospitalizada por una pielonefritis aguda. Estaba en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Durante el día está tranquila, pero en la noche se agita y dice que la tienen secuestrada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar benzodiacepinas en la noche
B) Indicar haloperidol oral
C) Agregar glibenclamida al tratamiento
D) Disminuir la dosis de metformina
E) Administrar suero fisiológico

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un delirium. Se trata, tratando la causa, pero sirve dar haldol en bajas dosis (también sirve la risperidona en bajas dosis, aunque no ha demostrado ser mejor que el Haldol). Para el manejo de la diabetes, está indicada la insulina, en este caso. Las BDZ están contraindicadas.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 168 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Paciente de 76 años, con antecedentes de HTA en tratamiento, es hospitalizado por neumonía requiriendo antibióticos endovenosos. Estando hospitalizado comienza con desorientación temporoespacial, inatención y pensamiento desorganizado, de curso fluctuante durante el día. El diagnóstico más probable es:

A) Demencia senil
B) Demencia frontotemporal
C) Esquizofrenia
D) Trastorno delirante crónico
E) Delirium

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Delirium** (opción **E**). Delirium de libro. Siempre preguntan varios delirium o síndrome confusional agudo.. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 119 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Una paciente de 74 años hospitalizada, desde hace una semana, por una fractura de cadera. Ha presentado cambios en su conducta, ya que al inicio era amable y cooperadora, pero en el último tiempo se ha agitado y mostrado confusa, e incluso ha llegado a agredir a otros pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Trastorno delirante
C) Esquizofrenia
D) Demencia vascular
E) Delírium

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Diagnóstico: **Delírium** (opción **E**). Es un síndrome confusional agudo o delirium clásico.. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 130 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Una mujer de 75 años, sufre caída a nivel presentando fractura de cuello femoral, por lo que se realiza prótesis total de cadera. Luego de la cirugía comienza a hablar incoherencias, se agita, se vuelve agresiva y además presenta desorientación temporoespacial. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de esta paciente?

A) Risperidona v.o
B) Haloperidol e.v
C) Diazepam i.m
D) Lorazepam e.v
E) Midazolam e.v

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene un delirium. Lo más importante es tratar la causa. La agitación, se puede tratar con haloperidol, intramuscular en la dosis más baja posible y luego, se mantiene con la mitad de la dosis, por vía oral. Idealmente no darlo ev, aunque el uptodate pone Haldol ev, como tratamiento de elección, ya que la dosis es muy bajita: 0,5 a 1 mg. La risperidona oral sirve mucho también, pero si está agitado, puede ser difícil de entregarlo. Es pregunta muy discutible, ya que ambos medicamentos han demostrado ser iguales en efectividad, aunque faltan estudios más concluyentes, por lo que el haldol sigue siendo de elección. Yo marcaría Haloperidol, como primera opción, pero al salir risperidona vo y haldol ev, no estoy seguro. Habría que revisar cómo estaba redactada la pregunta. [Respuesta oficial: B-A]

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 131 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Una paciente de 75 años, con historia de enfermedad de Alzheimer de 3 años de evolución, con buena funcionalidad presenta un cuadro en que agrede a otras personas y se muestra muy angustiada. Al examen físico le cuesta nombrar algunos objetos, no puede decir los días de la semana de manera invertida y se muestra poco atenta. Además, refiere que su padre ya fallecido está presente en la sala. Se hospitaliza para estudio y manejo y, al inicio, se muestra cooperadora y amable, pero luego exige que la dejen ir e intenta escapar del hospital y agredir al personal de salud. ¿Cuál es el fármaco inicial para el manejo de esta paciente?

A) Clorpromazina
B) Diazepam
C) Mirtazapina
D) Alprazolam
E) Haloperidol

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene un delírium o síndrome confusional agudo clásico. Se trata con el manejo de la patología de base (ej. infecciones, infartos, etc.) y con antipsicóticos, de preferencia haloperidol en dosis bajas (0,5 mg IM) o bien, risperidona 0,5 a 1 mg VO.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 127 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Adulta mayor con Parkinson hospitalizada por ITU, presenta desorientación e ideas deliriosas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado (además de tratar la ITU)?

A) Haloperidol IM
B) Lorazepam oral
C) Risperidona a bajas dosis
D) Quetiapina oral
E) Contención física y ambiental

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Risperidona a bajas dosis** (opción **C**). Risperidona a bajas dosis. Tratamiento general: observación + AINEs para dolor leve De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 96 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Un paciente de 84 años es traído a urgencia por familiares. Refieren que sus síntomas iniciaron hace 7 días, consistentes en tos con expectoración purulenta, sensación febril y disnea de esfuerzos. En las últimas noches se ha levantado algo agitado y anoche estuvo muy agitado, gritando que habían entrado extraterrestres en su casa y que lo querían matar. Al examen físico, tiene T°: 37,9°C, PA: 154/100, FC: 88x', FR: 25x', satura: 93% a FiO2 ambienta, tiene examen pulmonar con crepitaciones en la base derecha y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos sin soplos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Accidente vascular encefálico
B) Delirium
C) Epilepsia del lóbulo temporal
D) Demencia tipo Alzheimer
E) Esquizofrenia paranoide

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Epilepsia del lóbulo temporal** (opción **C**). Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 65 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Una paciente de 70 años, con antecedente de enfermedad de Parkinson, presenta un cuadro de 4 días de evolución de disuria e incontinencia urinaria, a lo que se ha agregado malestar general y, desde ayer, ha presentado agitación y desorientación, creyendo que la quieren atacar. Su examen físico muestra T°:38,3°C, FC: 80x', PA: 122/82 mmHg, desorientación en el tiempo y espacio, asociada a angustia, examen cardiopulmonar normal, examen abdominal con abdomen blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal. Dolor a la percusión de la fosa lumbar izquierda. Se solicitan exámenes, que muestran hemograma con leucocitosis de 14.000 por mm3 y VHS: 50 mm/h, sedimento de orina con abundantes bacterias, 20 glóbulos blancos por campo y 12 glóbulos rojos por campo y urocultivo que está pendiente. Se inicia ceftriaxona endovenosa, aunque intenta escaparse, ya que permanece agitada. ¿Qué medicamento es más adecuado para el manejo del cuadro actual?

A) Risperidona
B) Alprazolam
C) Quetiapina
D) Haloperidol
E) Clorpomazina

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Alprazolam** (opción **B**). Tratamiento general: observación + AINEs para dolor leve De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 64 · 1.07.2.005 · Síndrome confusional agudo

Persona hospitalizada operada hace unos días clinica sugiere: a. Delirium

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Ninguna de las anteriores es correcta). Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 56 · 7.01.3.031 · Estrategias de control de

Durante una pandemia respiratoria, el Ministerio de Salud debe decidir la intervención de salud pública con mayor impacto para reducir la mortalidad poblacional a largo plazo. ¿Cuál es la medida más eficaz?

A) Profilaxis antibiótica masiva
B) Desinfección ambiental de espacios públicos
C) Cuarentena de contactos
D) Vacunación masiva de la población
E) Aislamiento de casos positivos solamente

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vacunación masiva es la intervención de salud pública con mayor impacto en mortalidad por enfermedades infecciosas respiratorias. Genera inmunidad de rebaño, protege a los no vacunados y es costo-efectiva. Las demás medidas son complementarias pero no sustituyen a la vacunación.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 67 · 7.01.3.031 · Estrategias de control de

¿Cuál de las siguientes vacunas optativas se puede se puede recomendar a un niño de 2 meses?

A) Virus hepatitis A
B) Varicela
C) Neumocócica polisacárida
D) Influenza
E) Rotavirus

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Actualmente la vacuna antivaricela y antiVHA no son optativas, pero se dan después del año de edad, a los 18 meses, según el PNI. La neumocócica está en el PNI, pero se da la conjugada en menores de dos años (2, 4 y 12 meses; prematuros también 6 meses) y no la polisacárida. La de la influenza se da desde los 6 meses, durante la campaña de vacunación anual. La del rotavirus es electiva, se da a los 2 y 4 meses, reduce las hospitalizaciones por diarrea, podría aumentar el riesgo de intususcepción (probablemente no, pero igual la contraindica) y por ser a virus vivo, puede producir fiebre, diarrea y está contraindicada en inmunosuprimidos.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 97 · 7.01.3.031 · Estrategias de control de

El programa nacional de inmunizaciones existe en nuestro país desde el año 1978 y está orientado a la prevención de enfermedades prevalentes y que son un problema de salud pública. Además de las vacunas obligatorias existen otras que pueden ser utilizadas de forma voluntaria y pagadas de forma particular, en este contexto se encuentra la vacuna del rotavirus. Al respecto, ¿Qué ha demostrado esta vacuna?

A) Disminuir la letalidad de la infección por rotavirus
B) Provee inmunidad hasta los 24 meses contra el rotavirus
C) Disminuye la tasa de hospitalizaciones secundarias a infección por rotavirus
D) Disminuye la tasa de contagiosidad de la infección por rotavirus
E) Disminuye la sintomatología durante la infección por rotavirus

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Disminuye la tasa de hospitalizaciones secundarias a infección por rotavirus). Es lo más útil que ha demostrado. Esta pregunta no debería existir.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 172 · 7.01.3.031 · Estrategias de control de

¿Cuál es el mayor beneficio que la vacunación contra el rotavirus, en menores de 6 meses ha demostrado hasta ahora?

A) Disminuir la mortalidad por cualquier causa de diarrea
B) Disminuir la cantidad de casos secundarios de infecciones de rotavirus
C) Disminución de la incidencia de infecciones por rotavirus
D) Disminución de las hospitalizaciones pediátricas
E) Disminución de los casos de intususcepción intestinal

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vacuna del rotavirus actualmente no está en el PNI, pero se puede indicar, de manera particular a los 2 y 4 meses. Es a virus vivo, se da vía oral y su beneficio es reducir las hospitalizaciones por rotavirus. Si bien sus efectos adversos más frecuentes son fiebre, irritabilidad y diarrea leve, su efecto más temido (por raro que sea) es la invaginación intestinal.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 3 · 7.01.3.031 · Estrategias de control de

Vacuna embarazada para prevenir enfermedad de hijo en los primeros meses de nacimiento: a. influenza

B) Varicela
C) Tres virica
D) Fiebre amarilla
E) Meningococo conjugada
E) Interrupción del embarazo

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 28 · 7.01.3.028 · Pruebas de screening (tami

Si se quiere determinar la utilidad de una prueba diagnóstica, ¿Qué técnica es la más adecuada?

A) Elaboración de curvas de ROC
B) Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba
C) Determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad
D) Determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba
E) Determinar el número necesario para tratar (NNT)

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El cálculo de la Sensibilidad y Especificidad es la clásica forma de determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. Eso sí, también sirven las curvas de ROC, que justamente comparan sensibilidad vs. especificidad, de modo de identificar el valor de corte óptimo y comparar distintas pruebas diagnósticas. Sin embargo, las curvas de ROC solo sirven para test que miden variables cuantitativas y además requieren previamente de la determinación de la sensibilidad y la especificidad.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 43 · 7.01.3.028 · Pruebas de screening (tami

Una prueba de tamizaje obligatoriamente debe tener:

A) Alta especificidad, sin importar la sensibilidad
B) Alta sensibilidad, independiente de la especificidad
C) Alto valor predictivo positivo y facilidad en su aplicación
D) Bajo valor predictivo negativo y reproductibilidad
E) Bajo costo y baja sensibilidad

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La sensibilidad debe ser alta, para detectar todos los casos, aunque la especificidad no sea tan alta (por ello, luego se confirma con otros exámenes más específicos).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 141 · 7.01.3.028 · Pruebas de screening (tami

¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un test de tamizaje, para la detec- ción de cáncer, es efectivo?

A) Disminución de la tasa de incidencia
B) Disminución de la tasa de prevalencia
C) Disminución de la tasa de letalidad
D) Disminución de la tasa de mortalidad
E) Aumento de la supervivencia de la enfermedad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
C? El tamizaje no baja la incidencia. La prevalencia baja tanto porque se mejoran, como porque se mueren. La letalidad es un buen indicador, porque al diagnosticar pre- cozmente, se evita la muerte. La mortalidad también sería un indicado bueno, menos exacta, pero más disponible.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 60 · 7.01.3.028 · Pruebas de screening (tami

¿Cuál de las siguientes características del Elisa permite detectar a los pacientes con infección por el VIH, en la población asintomática?

A) Alta sensibilidad
B) Baja especificidad
C) Alta especificidad
D) Alto valor predictivo positivo
E) Alto valor predictivo negativi

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Recordar que las pruebas de screening requieren una alta S y toleran una E intermedia. En cambio, las pruebas confirmatorias necesitan una alta E y también necesitan que la S siga siendo elevada.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 122 · 7.01.3.028 · Pruebas de screening (tami

¿Cuál de las siguientes opciones representa la mejor estrategia para la detección temprana del cáncer testicular en la población en riesgo?

A) Niveles plasmáticos de alfafetoproteína
B) Establecer consultorios especializados para pacientes con dolor testicular
C) Implementar campañas de autoexamen testicular
D) Realizar ecografías testiculares como prueba de detección
E) Solicitar niveles plasmáticos de gonadotropina coriónica humana

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Screening de Cáncer Testicular: La ecografía testicular, aunque útil para diagnosticar tumores, no se recomienda como prueba de screening. Las guías internacionales se enfocan en el autoexamen testicular, aunque la evidencia de su utilidad es limitada.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 101 · 7.01.3.028 · Pruebas de screening (tami

Se desea implementar un método de screening para una enfermedad. El nuevo examen debe ser capaz de detectar la enfermedad en el periodo:

A) Entre los cambios tisulares y la aparición clínica
B) Posterior a la aparición clínica de la enfermedad
C) Previo a los primeros cambios bioquímicos
D) Entre los cambios bioquímicos y los cambios tisulares
E) De remisión

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Antes de los cambios bioquímicos no se puede detectar nada. Después de los cambios tisulares ya tengo daño. Ejemplo: glicemia de ayuno como screening de DM2. De todos modos es una mala pregunta porque depende de la enfermedad y del tipo de test: ejemplo el PAP hace el screening después de los cambios tisulares.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 71 · 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso – control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?

A) Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 – 4,01]
B) Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 – 3,17]
C) Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]
D) Exposición a radiación: OR: 1,52 ; IC [0,91 – 2,01]
E) Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 – 6,2]

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]). La opción C era la única estadísticamente significativa, ya que el OR no pasaba por el 1.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 31 · 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

¿Cuál de las siguientes medidas de asociación es más adecuada para establecer cuántas veces aumentan los casos de asma en la población fumadora, en comparación a la población no fumadora?

A) Riesgo relativo
B) Riesgo atribuible
C) Razón de prevalencias
D) Tasa de incidencia
E) Riesgo atribuible porcentual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Riesgo relativo). Es la definición de RR, que es la razón de incidencias. B y E son medidas de impacto.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 103 · 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

La medida que mejor estima la diferencia de riesgo entre un grupo expuesto y otro no expuestoa un factor de riesgo en una misma población es:

A) Riesgo atribuible
B) Odds Ratio
C) Riesgo Relativo
D) Incidencia acumulada
E) Razón de incidencias

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Riesgo atribuible). Es la definición de RA = Ie - Io. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 35 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

Se realiza un estudio de cohortes que busca establecer la asociación entre la exposición a estrógenos y el cáncer de ovario. Luego de analizar los datos, se obtiene que el Odds Ratio es 1,3 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 0,86 y 2,1. Con estos resultados se puede afirmar que:

A) Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 1,3 veces más riesgo de presentar cáncer de ovario

B) Las mujeres expuestas a estrógeno tienen 30% más de riesgo de presentar cáncer de ovario

C) Existe una asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es significativa

D) Las mujeres que tienen cáncer de ovario estuvieron expuestas a un 30% más de estrógeno

E) Se prueba la asociación entre el uso de estrógenos y el desarrollo de cáncer de ovario, pero no es extrapolable

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

OR mayor a 1, muestra una asociación con aumento del riesgo; sin embargo, el IC, que pasa por el 1 (0,86 es menor a 1 y 2,1 es mayor a 1), hace que no exista una asociación significativa.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 92 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso – control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%, obteniéndose los resultados hipotéticos que se muestran a continuación. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?

A) Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 – 4,01]

B) Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 – 3,17]

C) Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]

D) Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 – 6,2]

E) Exposición a radiación: OR: 1,89 ; IC [1,0 – 3,01]

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta rara, por la forma en que está redactada la pregunta, pero A, B, D y E pasan por el 1 y, por tanto, no son significativas. Solo la C, el sexo masculino es un factor protector, ya que tiene un OR menor a 1 (disminuye el riesgo) y, además, no pasa por el 1 (tanto 0,33 como 0,87 son menores a 1).

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 29 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

Se realiza un estudio de casos y controles que busca establecer la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y cáncer. Luego de analizar los datos se obtiene que el Odds Ratio 1,3 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 0,86 y 2,1. Con estos resultados se puede afirmar que:

A) Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer

B) Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero que no es estadísticamete significativa

C) Existe una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero este resultado no es extrapolable a otras poblaciones

D) Las personas que tienen cáncer consumen un 30% más de anticonceptivos orales

E) Las personas que usan anticonceptivos orales, tienen 1,3 veces más riesgo de desarrollar cáncer.

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El OR pasa por el 1,0 en su intervalo de confianza al 95%, por lo que no es estadísti- camente significativo.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 46 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

Un estudio investiga la correlación entre el uso de drogas durante el embarazo y las alteraciones cognitivas en los niños. Para ello, se selecciona a un grupo de niños con discapacidad cognitiva y se compara con otro grupo de niños sanos, realizándole una entrevista a la madre, sobre la exposición a distintos factores de riesgo, durante el embarazo. ¿Qué medida de asociación se debe utilizar en este estudio?

A) Riesgo relativo

B) Riesgo atribuible

C) Riesgo atribuible poblacional

D) Odds ratio

E) Incidencia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un estudio de casos y controles, por lo que se calcula el OR, como medida de asociación. El riesgo relativo también era una medida de asociación (las demás no).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 7 7.01.3.019 · Medidas de asociación e im

Un estudio investiga la correlación entre el desarrollo de alteraciones cognitivas en los niños y el uso de drogas durante el embarazo. Para ello, se selecciona a un grupo de niños con discapacidad cognitiva y se compara con otro grupo de niños sanos, realizándole una entrevista a los padres, sobre la exposición a distintos factores de riesgo, durante el embarazo. ¿Qué medida de asociación es la más adecuada para utilizar en este estudio?

A) Riesgo relativo

B) Riesgo atribuible

C) Riesgo atribuible poblacional

D) Odds ratio

E) Incidencia

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un estudio de casos y controles clásico, por lo que el OR se usa para medir la asociación. En cambio, en cohortes y ensayos clínicos se usa el RR.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 2 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿Cuál es el mejor indicador para medir la efectividad de la campaña de vacunación contra la influenza?

A) La tasa de mortalidad por influenza

B) La tasa de letalidad de la influenza

C) La tasa de incidencia de influenza

D) La tasa de prevalencia de influenza

E) La tasa de cobertura de vacunación contra la influenza

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Las vacunas intentan disminuir la incidencia de las patologías infecciosas y esa es la forma en que se mide su efectividad. Sin embargo, hay algunas vacunas que solo logran disminuir los casos graves (ej. rotavirus y recientemente Covid-19 en contra de las variantes del virus).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 20 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿A qué indicador corresponde la siguiente ecuación? (Muertes en menores de 28 días / nacidos vivos) x 1.000

A) Tasa de mortalidad infantil
B) Tasa de mortalidad perinatal
C) Tasa de mortalidad neonatal
D) Tasa de mortalidad neonatal precoz
E) Tasa de mortalidad postneonatal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Tasa de mortalidad perinatal). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Tasa de mortalidad infantil, Tasa de mortalidad neonatal) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 122 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿Cuál de los siguientes indicadores es de elección para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

A) Mortalidad mensual por influenza
B) Tasa de cobertura de vacunación
C) Incidencia semanal por influenza
D) Prevalencia de influenza
E) Letalidad mensual de la influenza

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Tasa de cobertura de vacunación). La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 2 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿Cuál es el mejor indicador para evaluar la efectividad de una campaña de vacunación contra la influenza?

A) Tasa de mortalidad por influenza
B) Cobertura vacunal alcanzada
C) Tasa de incidencia semanal
D) Número de hospitalizaciones evitadas
E) Porcentaje de población inmunizada

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Tasa de incidencia semanal). Tasa de incidencia semanal. La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 3 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

El indicador de letalidad de la influenza corresponde a lo siguiente:

A) Casos de influenza / población general
B) Casos de influenza / muertes influenza
C) Casos de influenza / población expuesta
D) Muertes por influenza / Casos de influenza
E) Muertes por influenza / población general

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La letalidad son las muertes/casos, es decir, la probabilidad de morirse si es que se enferma. La incidencia son casos/población. La mortalidad es muertes/población. El ataque es la incidencia durante un brote, tomando en cuenta solo la población expuesta al riesgo: muestra muy claramente la trasmisibilidad. Population (in millions>

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 51 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

Mueren 7 niños menores de 1 año por cada 1000 RNV. Cómo se llama el parámetro: a. Tasa de mortalidad infantil

B) Tasa de mortalidad Neonatal
C) Mortalidad neonatal tardía
D) Mortalidad
E) Letalidad
E) Control sano habitual

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Tasa de mortalidad Neonatal, Mortalidad neonatal tardía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 3 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿A qué corresponde el siguiente indicador: "Muertes antes de los 28 días / Total de nacidos vivos"?

A) Tasa de mortalidad perinatal
B) Tasa de mortalidad neonatal
C) Tasa de mortalidad infantil
D) Tasa de mortalidad posneonatal
E) Índice de mortalidad materna

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Tasa de mortalidad neonatal). Tasa de mortalidad neonatal. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 100 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿Cuál es el indicador que más se utiliza para reflejar el nivel de desarrollo de los países?

A) Tasa de morbilidad general
B) Tasa de mortalidad general
C) Tasa de fecundidad
D) Tasa de natalidad
E) Tasa de mortalidad infantil

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La mortalidad infantil refleja muy bien el desarrollo de los países, junto a la expectativa de vida.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 137 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al indicador de letalidad por influenza?

A) Número de casos de influenza / Número de fallecidos por influenza
B) Número de fallecidos por influenza / Población general
C) Número de casos de influenza / Población general
D) Número de fallecidos por influenza / Número de casos de influenza
E) Número de casos de influenza / Población expuesta

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Letalidad: La letalidad se define como la probabilidad de morir si se contrae una enfermedad. Se calcula dividiendo el número de muertes causadas por la enfermedad entre el total de casos de esa enfermedad.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 119 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

Durante el año 2012 en Chile se presentaron 60 casos de meningitis causadas por la Neisseria Meningitidis serotipo W135, de los cuales 20 fallecieron por causa atribuible a esta enfermedad. Por lo tanto la letalidad de la N.Meningitidis serotipo W135 durante el 2013 fue:

A) 25%
B) 66%
C) 50%
D) 33%
E) 75%

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (33%). 20/60 = 0,33 = 33%. Esta clase revisa el diagnóstico y manejo de la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 14 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

Tras analizar una tabla que compara la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad proporcional para dis8ntas patologías entre un periodo inicial y uno tardío: ¿Qué conclusión es posible obtener?

A) La variación en la mortalidad proporcional se explica por las variaciones en la tasa de mortalidad de dicha enfermedad
B) La tasa de mortalidad por cáncer y por otras causas se mantuvo constante en el 2empo
C) El aumento en la tasa de mortalidad por patología cardiovascular se debe al envejecimiento de la población
D) La disminución de la proporción de pacientes que mueren por cáncer y otras causas se explica por la disminución de la mortalidad por dichas causas
E) La tasa de mortalidad general se man2ene estable

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque al inicio parece difícil, es una pregunta bastante sencilla. La mortalidad por patología cardiovascular sube de 60/1000 a 150/1000. En cambio la mortalidad por cáncer y por otras causas se mantienen constantes en 30/1000 cada una (por eso es correcta la B y falsa la D). Con esto, aumenta la mortalidad general de 120/1000 a 210/1000 (por tanto, es falsa la E) y cambian las mortalidades proporcionales, subiendo el porcentaje de muertes por patología cardiovascular y disminuyendo las por cáncer y por otras causas. Vale la pena explicar la opción A, cuya redacción es algo difícil de entender y, de hecho, sería verdadera si solo se tratara a la patología cardiovascular, pero no es verdadera para el cáncer o las otras causas, ya que la variación en la mortalidad proporcional por esas causas no se debe a la variación de la mortalidad por esas causas, sino solo a la variación de la mortalidad por patología cardiovascular.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 67 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

La tasa de natalidad de un país se calcula como el número de nacidos vivos en un año dividido por la población total a mediados de año, multiplicado por 1.000. ¿Cuál es el denominador correcto de este indicador?

A) Población total a mediados del año
B) Número de mujeres en edad fértil
C) Número de embarazos totales
D) Población mayor de 15 años
E) Total de defunciones del año

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tasa bruta de natalidad = (nacidos vivos en el año / población total a mitad del año) × 1.000. El denominador es la población total (no solo mujeres fértiles, que corresponde a la tasa de fecundidad).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 67 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿Cuál de los siguientes parámetros es más adecuado para determinar la gravedad de una enfermedad?

A) Años de vida saludable perdidos
B) Tasa de mortalidad
C) Tasa de letalidad
D) Tasa de incidencia
E) Tasa de ataque

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
, C?. La letalidad es un indicador clásico de gravedad, pero los años de vida saludables perdidos también lo son, e incluso es mejor, cuando se trata de enfermedades graves, pero que no causan la muerte, sino que dejan secuelas y causan invalidez. Yo marqué C.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 80 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

¿A qué indicador corresponde la siguiente afirmación "De 100 pacientes tuberculosos, 13 fallecen"?

A) Valor absoluto
B) Razón
C) Frecuencia relativa
D) Índice
E) Tasa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Tasa). Es la tasa de letalidad (probabilidad de fallecer si se enferma).. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 132 · 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

Durante el año 2012 hubo una natalidad en Chile de 13.9 por cada 1000 habitantes y en Estados Unidos de 12.5 por cada 1000 habitantes. Se desean comparar ambos índices, ¿Cuál de los siguientes parámetros es más útil para este propósito?

A) Razón
B) Proporción
C) Número absoluto
D) Índice
E) Tasa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Esa pregunta no se entiende en absoluto. Se comparan las tasas de natalidad y es más, las están dando. La pregunta dice "índices" y toda tasa es una razón. Además se puede calcular la razón entre ambas tasas de natalidad y así decir qué tan mayor/ menor es la natalidad de un país comparado con la del otro. Plop! Sin embargo, lo que se compara son las tasas de natalidad y por tanto esa es la respuesta.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 74 · 7.01.3.009 · Indicadores de nivel de sa

Si se mejorara el tratamiento de una enfermedad crónica, y se mantiene la incidencia, ¿que pasaría con la prevalencia?

A) Aumenta
B) No se modifica
C) Disminuye
D) No se puede saber
E) Depende de la enfermedad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Al mejorar el tratamiento, mueren menos enfermos, pero al seguir la incidencia, hay más casos cada vez (mismos casos nuevos y más casos antiguos que no murieron), por lo que aumenta la prevalencia.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 110 · 7.01.3.022 · Estudios de casos y contro

¿Cuál es el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes?

A) Cohortes prospectivas
B) Caso control
C) De prevalencia
D) Ensayo clínico
E) Cohortes retrospectiva

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Casos y controles sirve más que los estudios de cohortes en 1. enfermedades raras, 2. enfermedades que demoran mucho tiempo en aparecer, 3. casos en que hay déficit de presupuesto (son más baratos).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 92 · 7.01.3.022 · Estudios de casos y contro

¿Cuál es el mejor tipo de estudio para enfermedades poco prevalentes?

A) Serie de casos
B) Estudio de cohortes
C) Ensayo clínico
D) Estudio ecológico
E) Estudios de caso-control

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Casos y controels sirven para: poco prevalentes, bajo presupuesto y enfermedades que demoran mucho en aparecer.

EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 147 · 7.01.3.022 · Estudios de casos y contro

Se realiza un estudio donde se desea estudiar los factores de riesgos asociado al lupus, por esto se seleccionan dos grupos, uno de ellos con pacientes diagnosticadas de lupus y el otro de características demográficas similares pero sanos. ¿A qué tipo de estudio corresponde el diseño mencionado anteriormente?

A) Cohorte prospectivo
B) Prevalencia
C) Caso control
D) Ensayo clínico controlado
E) Estudio ecológico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Falta decir qué se hace con esos pacientes. Si se les preguntan sus factores de riesgo (si fuman, toman, etc) sería casos y controles. No puede ser cohortes, porque no se va a a ver a futuro qué FR desarrollan (sería ilógico), porque ya están enfermos o sanos.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 128 · 7.01.3.049 · Financiamiento del sector

¿Cómo se financia el Plan de Salud Familiar, ofrecido por el sistema de atención primaria de salud de Chile?

A) Transferencias por prestaciones otorgadas
B) Aportes de fondos municipales
C) Transferencias por plan de salud
D) Aporte per cápita, en razón del número de inscritos
E) Copago de los usuarios

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La salud primaria, por regla general, se financia con el aporte per cápita (que se asigna a la salud primaria, en base al número de inscritos), seguido luego por los aportes municipales (en las municipalidades con más recursos, es mayor). El Plan de Salud Familiar es el conjunto de prestaciones de salud enfocada en las necesidades de atención primaria (incluye una canasta de prestaciones en salud del niño, de la mujer, de los adultos y adultos mayores, tanto médica como odontológica y demás áreas de salud primaria) e y considera todos los costos asistenciales de la salud primaria (el aporte per cápita financia estos costos asistenciales, más los costos de administración).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 94 · 7.01.3.049 · Financiamiento del sector

¿Cómo se financia el seguro público de salud?

A) El aporte estatal, desde los impuestos generales
B) El aporte tripartito del estado, los empleadores y trabajadores
C) El aporte de las mutuales
D) El 7% de los trabajadores
E) El aporte de los empleadores

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Fonasa se financia por el aporte estatal (el estado se financia por los impuestos). En segundo lugar por el aporte de los trabajadores. Los empleadores no aportan.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 42 7.01.3.049 · Financiamiento del sector

En Chile, el financiamiento de la seguridad social relacionada a los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales viene dado principalmente por:

A) El aporte de Fonasa y las Isapres
B) Financiamiento tripartito (Estado, trabajadores y empleadores)
C) El 7% de aporte de los trabajadores
D) El aporte estatal directo
E) Aporte patronal de 0,85% del sueldo del trabajador

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es el aporte del empleador, que varía según el tipo de empresa, entre 0% y 3,4%. La salud general, en cambio, se financia con el aporte estatal (lo más importante en Fonasa), más el 7% de los trabajadores (tanto Fonasa como Isapres)

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 95 7.01.3.038 · Definición, estructura y f

Las instituciones de salud previsional y el seguro público de salud tienen en salud que:

A) Administrar el seguro de cotización individual
B) Administran el seguro público de salud
C) Administrar los fondos para las garantías de salud, comprendidas en el plan AUGE
D) Administran el seguro general de salud
E) Dan prestaciones de salud

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tanto las Isapres, como Fonasa administran los fondos AUGE. Las Isapres adminstran el seguro de cotización individual y Fonasa el seguro público. No sé qué es el seguro general. Ninguna dan prestaciones de salud, porque son seguros, no prestadores,

---

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 127 7.01.3.038 · Definición, estructura y f

¿Qué institución del sistema de salud chileno es la encargada de cursar las autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de los establecimientos de salud?

A) Instituto de Salud Pública
B) Secretaría Regional Ministerial de Salud
C) Superintendencia de Seguridad Social
D) Superintendencia de Salud
E) Servicio de Salud

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las autorizaciones sanitarias las cursa la Seremi de Salud, desde el funcionamiento de restaurantes, hasta la necesaria para una sala de procedimientos, UCI, hospital, farmacia, laboratorio, etc. Dato útil: las consultas médicas en las que no se realizan procedimientos no requieren autorización sanitaria. En el caso de farmacias y laboratorios, su fiscalización la realiza el ISP en todo lo relacionado con los medicamentos, pero también la Seremi, respecto de la normativa sanitaria.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 97 7.01.3.038 · Definición, estructura y f

¿Qué instituciones están encargadas de administrar el seguro de la salud laboral, accidentes del trabajo y del trayecto?

A) Instituciones de Salud Previsional
B) Instituto de Salud Laboral
C) Superintendencia de Seguridad Social
D) Instituto Nacional de Previsión
E) Mutualidades de empleadores

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **E** (Mutualidades de empleadores). Son las mutuales (mutual de seguridad, ACHS).. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 18 7.01.3.047 · Auditoría y acreditación

¿A qué tipo de garantía corresponde el registro de los profesionales de la salud en el Registro de Prestadores Individuales, llevado por la Superintendencia de Salud, en contexto del programa de Garantías Explícitas de Salud (GES)?

A) Garantía de acceso universal
B) Garantía de protección financiera
C) Garantía de calidad en la atención
D) Garantía de oportunidad en la atención
E) Garantía de acceso a la información

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Garantías GES: acceso universal (FONASA e ISAPRE), protección financiera (subsidio estatal), calidad (fiscalización por Superintendencia de Salud, acreditación y registro de prestadores individuales e institucionales), oportunidad (plazos para prestaciones GES). El acceso a la información no es una garantía GES, sino de la ley de Derechos y Deberes del Paciente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 96 7.01.3.047 · Auditoría y acreditación

¿Qué institución es la encargada de acreditar y autorizar a los prestadores individuales de salud y a los centros de salud?

A) La superintendencia de seguridad social
B) La autoridad regional sanitaria
C) La superintendencia de salud
D) Fonasa
E) La municipalidad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (La superintendencia de salud). Es función de la Superintendencia de salud. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 82 7.01.3.047 · Auditoría y acreditación

¿Cuál de las siguiente actividades o medidas, está relacionado con el principio de ca- lidad de las garantías explícitas de salud (GES)?:

A) Autorización sanitaria de prestadores y laboratorios
B) Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud
C) Vigilancia del cumplimiento de plazos
D) Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud
E) Vigilancia epidemiológica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud). La certificación asegura que el prestador cumple con los estándares de calidad.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 42 7.01.3.047 · Auditoría y acreditación

¿Cuál de las siguiente actividades o medidas de las garantías explícitas de salud (GES), está relacionado con la garantía de calidad?

A) Autorización sanitaria de los prestadores de salud
B) Acreditación de los prestadores de salud
C) Vigilancia del cumplimiento de plazos
D) Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud
E) Subsidio estatal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La autorización sanitaria (Seremi) sí se exige para acreditar al prestador (por la Superintendencia), lo que hace que sea un distractor fuerte, pero la acreditación es el acto que muestra la calidad. Los plazos se relacionan con el principio de oportunidad. Los convenios con Isapres y Fonasa se relacionan con el principio de acceso universal. El subsidio estatal se relaciona con el principio de protección financiera.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 19 7.01.3.047 · Auditoría y acreditación

¿A qué tipo de garantía corresponde el registro de los profesionales de la salud en el Registro de Prestadores Individuales, llevado por la Superintendencia de Salud, en contexto del programa de Garantías Explícitas de Salud (GES)?

A) Garantía de acceso universal
B) Garantía de protección financiera
C) Garantía de calidad en la atención
D) Garantía de oportunidad en la atención
E) Garantía de acceso a la información

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Garantías GES (Garantías Explícitas en Salud): En Chile, estas garantías son: garantía de acceso universal (acceso a la cobertura GES tanto a los afiliados a FONASA como a ISAPRE); garantía de protección financiera (subsidio estatal para acceso a prestaciones a un precio más bajo); garantía de calidad (asegurada por la fiscalización de la Superintendencia de Salud, que se traduce en la acreditación y el registro de prestadores individuales e institucionales); y garantía de oportunidad (asegura el cumplimiento de plazos para la entrega de las prestaciones GES de forma oportuna). Es importante destacar que el acceso a la información no forma parte de las garantías GES, sino que está en la ley de Derechos y Deberes del Paciente. No se debe confundir la acreditación que da la SIS y que certifica la calidad para ser prestador Fonasa y GES, con la autorización sanitaria que da la Seremi de Salud y que permite el funcionamiento, una vez que se cumplen con los requisitos sanitarios.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 129 7.01.3.014 · Epidemiología descriptiva

Si se quiere hacer un estudio donde se describe en un grupo de niños cuales son los FR, edad, enfermedades?, cómo se llamaría:

A) Analitico
B) Ecológico
C) Descriptivo
D) Control sano habitual
E) Derivar a especialista

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Descriptivo). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Analitico, Ecológico) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 98 7.01.3.014 · Epidemiología descriptiva

¿Qué significa que una enfermedad se endémica?

A) Que mantiene una frecuencia relativamente estable en la zona, con sus variaciones estacionales
B) Aquella que presenta muchos más casos, a los habituales para la zona geográfica
C) Que se extiene a todos los lugares del planeta
D) Aquella que presenta varios casos, relacionados entre sí, en un corto periodo de tiempo
E) Aquella que presenta casos escasos, sin poder identificar un patrón

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es la definición de endemia. Pandemia se extiende al todo el mundo. Epidemia tiene aumentos mayores a lo habitual. Brote son varios casos relacionados.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 47 7.01.3.014 · Epidemiología descriptiva

Si se mejorara el tratamiento de una enfermedad crónica, y se mantiene la incidencia, ¿qué pasará con la prevalencia?

A) Aumenta
B) No se modifica
C) Disminuye
D) No se puede determinar
E) Depende de la enfermedad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si la enfermedad crónica es incurable, al mejorar el tratamiento, se muere menos gente y aumenta la prevalencia. Si fuera curable, sí disminuiría la prevalencia, ya que se curarían. Sin embargo, la D y la E hacen pensar que la respuesta que se quería como correcta era la A.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 177 7.01.3.014 · Epidemiología descriptiva

"Número de casos nuevos de una enfermedad en la población susceptible en un determinado tiempo." ¿A qué corresponde esta definición?

A) Tasa de prevalencia
B) Tasa de mortalidad específica
C) Tasa de incidencia
D) Tasa de ataque secundario
E) Odds ratio

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Tasa de incidencia). Tasa de incidencia. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Tasa de prevalencia, Tasa de mortalidad específica) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 152 7.01.3.014 · Epidemiología descriptiva

¿Cuál de las siguientes patologías no es autóctona de Chile?

A) Síndrome pulmonar por hantavirus
B) Leptospirosis
C) Influenza
D) Dengue
E) Malaria

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En Chile no hay malaria autóctona desde 1945, en que se erradicó el mosquito Anopheles de la zona norte. Todos los casos actuales son importados. El dengue únicamente está presente en Isla de Pascua.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 177 7.01.3.014 · Epidemiología descriptiva

Se calcula el número de casos nuevos de un determinado cáncer en una población, durante un periodo de tiempo y se relaciona con las personas susceptibles de enfermarse de dicha enfermedad al inicio del seguimiento. ¿A qué concepto corresponde esta descripción?

A) Incidencia acumulada
B) Tasa de ataque
C) Tasa de incidencia
D) Tasa de prevalencia
E) Tasa de letalidad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Incidencia acumulada). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Tasa de ataque, Tasa de incidencia) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 99 7.01.3.018 · Epidemiología analítica

¿Qué rama de la Salud Pública se preocupa de obtener información, a través del contraste de hipótesis?

A) Epidemiología descriptiva
B) Bioestadística
C) Prevención de salud
D) Epidemiología analítica
E) Vigilancia epidemiológica

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El contraste de hipótesis es la herramienta principal de la epidemiología analítica, que busca relaciones de causa-efecto.

EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 21 7.01.3.018 · Epidemiología analítica

Se realiza un estudio que muestra que en la comuna A, el consumo de drogas es de un 40%, mientras que en la comuna B, es de 10%. El diseño de estudio más adecuado, para determinar las causas de estas diferencias, es:

A) Ecológico
B) Descriptivo
C) Analítico
D) De prevalencia
E) De incidencia Respuesta: Las relaciones de causalidad, se estudian con la epidemiología analític

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Analítico). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Ecológico, Descriptivo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 127 1.07.3.007 · Manejo de fármacos en la p

Un paciente de 82 años, con múltiples patologías con tratamiento farmacológico, presenta TSH: 3,8 UI/L y hemoglobina glicosilada de 5,2%. ¿Qué fármaco debe suspender?

A) Vitamina D
B) Glibenclamida
C) Enalapril
D) Levotiroxina
E) Calcio

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
En los mayores de 75 años, el objetivo de la TSH es 3 a 6 UI/L, por lo que está bien y el objetivo de la HbA1c es menor a 8%, por lo que está sobretratado y no hay problema en suspender la glibenclamida, en especial, tomando en cuenta el riesgo de hipoglicemia. Los demás fármacos no están especialmente contraindicados.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 121 1.07.3.007 · Manejo de fármacos en la p

Un paciente de 80 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, hipotiroidismo y artrosis, en tratamiento con donepecilo, levotiroxina y paracetamol, presenta escapes frecuentes de orina y diarrea. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Agregar memantina
B) Disminuir la dosis de levotiroxina
C) Agregar oxibutinina
D) Disminuir la dosis de donepecilo
E) Aumentar la dosis de levotiroxina

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

El síndrome colinérgico: diarrea e incontinencia urinaria es una complicación frecuente del donepecilo. La metformina solo produce diarrea.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 9 1.07.3.007 · Manejo de fármacos en la p

Paciente 80 años con antecedente de artrosis en tratamiento con paracetamol 1 gr c/8 horas, con control parcial del dolor. Realiza adecuadamente sus actividades de la vida diaria, usa bastón y sale acompañada. Tiene antecedente de HTA e Insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional III. ¿Cuál es el mejor fármaco a agregar para continuar el manejo del dolor?

A) Ibuprofeno v.o.
B) Pregabalina v.o.
C) Ketorolaco v.o.
D) Lidocaína en parches
E) Tramadol v.o.

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Si bien los AINES son el tratamiento de segunda línea (paracetamol es de primera), en los pacientes hipertensos (mal controlados) y con insuficiencia cardiaca suelen estar contraindicados (por el riesgo de insuficiencia renal aguda), por lo que creo que la respuesta es tramadol (aunque habitualmente es de tercera línea). Aun así es una pregunta difícil, ya que no se es tan explícito en la contraindicación (otras contraindicaciones son úlcera por AINES y la IRC).

EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 108 1.07.3.007 · Manejo de fármacos en la p

Un paciente de 81 años presenta insomnio de conciliación y de mantención, que afecta sus actividades y lo tiene angustiado. Refiere que no duerme siesta. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de su insomnio?

A) Clonazepam
B) Diazepam
C) Midazolam
D) Alprazolam
E) Zolpidem

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La verdad es que todos los hipnóticos se deben evitar en el adulto mayor, por el riesgo de dependencia y lo más importante es indicar medidas generales de higiene del sueño. Si hay que elegir un hipnótico en el adulto mayor, debe ser el zolpidem, sin embargo sirve más para el insomnio de concialición y el paciente también tiene de mantención. Esta pregunta está mala, ya que sí se le pueden dejar benzodiacepinas a los adultos mayores y la evidencia no es concluyente. Igualmente creo que zolpidem será la respuesta correcta.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 160 1.07.3.007 · Manejo de fármacos en la p

Una mujer de 86 años, con múltiples patologías crónicas, en tratamiento farmacológico, acude a control, constatándose IMC: 23,frecuencia cardíaca: 76 lpm, presión arterial: 110/70 mmHg. Además trae exámenes, que muestran TSH: 2,65 UI/L, LDH: 152 UI/L, hemoglobina glicosilada: 5,2%, colesterol HDL: 35 mg/dl, colesterol total: 205 mg/dl. ¿Qué fármaco debería suspenderse?

A) Losartán
B) Atorvastatina
C) Levotiroxina
D) Carvedilol
E) Glibenclamida

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Tiene una HbA1c menor a 7%, de hecho, menor a 6%, que es lo normal. En el adulto mayor el objetivo es de 8%, por lo que no hay problema en suspender la glibenclamida y más aún, se puede disminuir el riesgo de hipoglicemias. Ninguno de los demás fármacos está contraindicado.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 63 1.07.3.007 · Manejo de fármacos en la p

Un paciente de 87 años, institucionalizado por una demencia tipo Alzheimer y que es portador de sonda Foley a permanencia, presenta orinas turbias, por lo que se realiza un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli sensible a nitrofurantoína, amikacina e imipenem. El paciente está en buenas condiciones, asintomático y sin mayor confusión de la habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar la sonda
B) Iniciar amikacina
C) Iniciar imipenem
D) Iniciar nitrofurantoína
E) Mantener sin tratamiento antibiótico

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Conducta / Tratamiento indicado: **Mantener sin tratamiento antibiótico** (opción **E**). Tiene una bacteriuria asintomática, por lo que se observa. Si hubiese tenido clínica de ITU. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 106 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

El médico de un CESFAM detecta un brote de hepatitis A en su sector. ¿A qué autoridad sanitaria debe notificar de forma inmediata?

A) SEREMI de Salud
B) Ministerio de Salud directamente
C) FONASA
D) ISP
E) Municipalidad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

En Chile, las enfermedades de notificación obligatoria inmediata (ENNOI) como brotes de hepatitis A se notifican al SEREMI de Salud de la región correspondiente dentro de las 24 horas.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 60 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

Usted atiende a 5 pacientes que consultan por vómitos y diarrea de inicio agudo en el mismo servicio de urgencia. Todos ellos son compañeros de trabajo, que almuerzan en el mismo comedor, por lo que se sospecha una intoxicación alimentaria. Además del manejo específico de los síntomas y patología de cada uno de ellos, la medida más adecuada es:

A) Notificar al encargado de epidemiología del Hospital
B) Realizar un interrogatorio detallado a cada uno de los pacientes, para identificar el agente causal
C) Notificar a la Seremi de Salud
D) Notificar al Director del Hospital
E) Notificar a la Superintendencia de Salud

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Notificación obligatoria de enfermedades: Los tres tipos de vigilancia epidemiológica son activa, centinela y pasiva. La notificación obligatoria es una estrategia de vigilancia activa. En Chile, existen dos tipos de notificación: inmediata y diaria. La notificación inmediata se utiliza para las enfermedades más virulentas y poco frecuentes. La notificación diaria se utiliza para enfermedades menos virulentas. En ambos casos, la notificación se realiza a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud ante la sola sospecha de la enfermedad. Esta notificación permite a las autoridades sanitarias tomar medidas urgentes para contener el contagio.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 44 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

¿Qué tipo de vigilancia se utiliza en patologías como las infecciones respiratorias altas, las diarreas y las enfermedades de trasmisión sexual?

A) Vigilancia activa
B) Vigilancia centinela
C) Vigilancia de notificación obligatoria
D) Estudios de prevalencia
E) Estudios experimentales

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vigilancia por centros centinelas se usa en las siguientes enfermedades: infecciones respiratorias altas, diarreas, varicela y las infecciones de trasmisión sexual (excepto la sífilis y gonorrea, que son de notificación obligatoria).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 98 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

¿Mediante qué estrategia epidemiológica se debe enfrentar la sospecha de un brote de intoxicación alimentaria para su adecuada iden8ficación y control?

A) Vigilancia ac2va
B) Estudio experimental
C) Vigilancia cen2nela
D) Estudio analí2co
E) Vigilancia pasiva

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las intoxicaciones alimentarias se manejan con vigilancia ac<va, es decir, con un sistema de no<ficación obligatoria. La misma estrategia aplica a infecciones graves y poco frecuentes (ej. sarampión, ébola, hanta, rabia, meningococcemia, ITS, brotes), bastando la sola sospecha para la noGficación. La vigilancia centinela, en cambio, se usa en infecciones frecuentes y no muy graves (virus respiratorios, diarreas, varicela). En ella, solo informan algunos centros de salud específicos, llamados centros centinela. La vigilancia pasiva solo se realiza en infecciones poco transmisibles o leves (ej. ITU, exantemas banales). En ellas simplemente se reportan estadísticas para analizarlas después.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 142 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

En la vigilancia de las enfermedades transmisibles, ¿cuál es el parámetro que se utiliza para definir si la notificación de los casos de dicha enfermedad es de tipo diaria o inmediata?

A) Periodo de incubación
B) Oportunidad de control y prevención
C) Letalidad y prevalencia
D) Número de casos
E) Disponibilidad de vacuna

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La velocidad con la que se notifica considera la gravedad de la enfermedad (letalidad) y la frecuencia de casos (más que prevalencia es la incidencia, pero es la única respuesta aceptable). En general solo se notifican enfermedades graves y que son infrecuentes y mientras más graves, se notifican más rápido.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 24 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

¿Cuál es la mejor estrategia de vigilancia para una enfermedad infectocontagiosa, que se transmite a través de la contaminación de acuíferos?

A) Vigilancia activa
B) Vigilancia pasiva
C) Vigilancia estacional
D) Encuestas
E) Centros centinelas

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Pregunta muy rara. La vigilancia activa de los acuíferos (aguas superficiales y aguas subterráneas) es lo más razonable, con toma de muestras y análisis periódicos de las aguas en cuestión, más análisis directo, en caso de reportarse casos sospechosos (por eso marcamos la vigilancia activa como respuesta). Pero la verdad es que, en Chile, las diarreas (incluyendo el cólera, por ejemplo), se vigilan mediante centros centinelas (hospitales o clínicas determinadas, que deben estudiar las etiologías y notificarlas a la Seremi de Salud). Sin embargo, dado que vigilancia activa y vigilancia pasiva son términos muy amplios, que abarcan todo lo demás, lo más probable es que quien redactó la pregunta apuntara a una de esas opciones.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 44 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

¿Por qué la meningococcemia es una enfermedad de notificación inmediata?

A) Para aislar a los contactos
B) Para vacunar a la familia
C) Para identificar y manejar a los contactos
D) Para detectar casos secundarios
E) Por la gravedad de la enfermedad

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si bien la vigilancia epidemiológica de este tipo (vigilancia activa) puede servir para todas las opciones, la respuesta más correcta y completa es la C. En el Covid-19 sí se aísla a los contactos, pero en la meningococcemia no se aíslan, sino que se les da profilaxis antibiótica (rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona).

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 41 · 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

La notificación obligatoria de ciertas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

A) Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población
B) Identificar las enfermedades infecciosas más importantes en la población
C) Determinar la propagación de las enfermedades más letales
D) Identificar y controlar situaciones epidémicas
E) Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La vigilancia activa (notificación obligatoria) busca identificar los brotes de manera rápida, para poder contenerlo, haciendo un adecuado manejo de los casos (aislamiento y tratamineto) y de los contactos (profilaxis y observación).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 107 · 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

Respecto al DIEP (Departamento de Infecciones y Epidemiología del Paciente) en hospitales chilenos, ¿cuál es su función principal?

A) Vigilar, prevenir y controlar las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS)
B) Gestionar los recursos humanos del hospital
C) Supervisar la farmacia hospitalaria
D) Coordinar las licencias médicas
E) Auditar los estados financieros del hospital

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El DIEP (o Comité de IAAS) en hospitales chilenos tiene como función primordial la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS).

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 5 · 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

La notificación obligatoria de algunas enfermedades transmisibles tiene como objetivo:

A) Evaluar la efectividad de las vacunas administradas a la población
B) Identificar las principales enfermedades transmisibles en la población
C) Determinar la propagación de las enfermedades infecciosas más importantes
D) Ayudar a identificar y controlar situaciones epidémicas
E) Reunir información estadística completa y confiable, para determinar las políticas de salud

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La notificación obligatoria es una medida de vigilancia activa, que busca conocer rápidamente sobre la presencia de casos de una enfermedad infecciosa, de modo de identificar y manejar a los contactos, tanto en brotes como en epidemias (y pandemias). La efectividad de vacunas se mide con ensayos clínicos o de campo. Las demás opciones se pueden lograr con un buen registro epidemiológico, sin necesidad de una notificación rápida.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 169 · 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

La notificación de las enfermedades transmisible está relacionada con el siguiente de los objetivos fundamentales de la Salud Pública:

A) Promoción de la salud
B) Protección de la salud
C) Prevención, vigilancia y control de enfermedades
D) Recopilación y análisis de información
E) Protección específica de la salud pública

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La notificación obligatoria de enfermedades es una medida de vigilancia epidemiológica activa, que busca tanto prevenir el contagio a más personas (prevención primaria), como diagnosticar oportunamente a los contactos (prevención secundaria) y, así, controlar los brotes de la enfermedad. Ej. Covid-19.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 116 · 7.01.3.016 · Vigilancia epidemiológica

Cómo medir la efectividad de una campaña de vacunación contra sarampión:

A) prevalencia
B) Casos sospechosos nuevos notificados (mi duda con esta es que decía sospechosos, la idea de una vacuna es disminuir la incidencia de los casos confirmados,
C) Seguimiento de los vacunados
D) Estudio de casos de la eficacia
E) Serología Ac de los casos sospechosos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Casos sospechosos nuevos notificados (mi duda con esta es que decía sospechosos, la idea de una vacuna es disminuir la incidencia de los casos confirmados,). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 51 · 7.01.3.006 · Determinantes del nivel de

Según la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, ¿cuál de los siguientes factores tiene mayor impacto en la salud de la población?

A) Nivel educacional
B) Vivienda
C) Alimentación
D) Ingreso económico
E) Acceso a servicios de salud

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La educación es el determinante social de la salud más potente y consistente: mayor educación → mejor comprensión de la salud, acceso a empleo estable, mayor ingreso y mejores hábitos. Actúa como determinante de otros determinantes. Reduce mortalidad de todas las causas.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 69 · 7.01.3.006 · Determinantes del nivel de

¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde con mayor probabilidad a una enfermedad laboral?

A) Dermatitis de contacto alérgica
B) Asma
C) Mesotelioma
D) Síndrome del manguito rotador
E) Trastorno adaptativo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los mesoteliomas son por exposición a asbesto. De todos modos, es una pregunta muy específica y además la frecuencia de mesoteliomas es muy baja en la actualidad (cerraron la empresa Pizarreño hace muchos años: era la que hacía placas de asbesto).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 116 · 7.01.3.006 · Determinantes del nivel de

En un gráfico de salud pública se observa que la tasa de mortalidad infantil ha disminuido progresivamente en los últimos 40 años en Chile. ¿Cuál es el principal determinante de esta tendencia?

A) Mejoras en condiciones socioeconómicas, educación materna y acceso a agua potable
B) Introducción de nuevos antibióticos
C) Vacunación masiva universal
D) Aumento del número de médicos
E) Disminución de la natalidad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La caída histórica de la mortalidad infantil se atribuye principalmente a determinantes sociales: mejor nivel educacional, condiciones sanitarias, acceso a agua potable y saneamiento, más que a intervenciones médicas aisladas.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 46 · 7.01.3.006 · Determinantes del nivel de

¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde con mayor probabilidad a una enfermedad laboral?

A) Dermatitis de contacto alérgica
B) Asma
C) Mesotelioma
D) Patología del manguito rotador
E) Cáncer de piel

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Todas pueden ser profesionales, pero el mesotelioma casi exclusivamente se da en contexto de exposición a asbesto en las plantas de producción. En Chile se cerraron hace algunos años atrás.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 108 · 7.01.3.006 · Determinantes del nivel de

Paciente encontrada en el baño con compromiso de conciencia y calefont apagado, saturación O2 normal en urgencias. ¿Cuál es el examen de elección?

A) Carboxihemoglobina
B) Gases arteriales convencionales
C) TAC de cerebro sin contraste
D) Niveles de cianuro en sangre
E) Hemograma y electrolitos

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Carboxihemoglobina). Carboxihemoglobina. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Gases arteriales convencionales, TAC de cerebro sin contraste) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 87 · 7.01.3.020 · Diseños de investigación e

¿Cuál es el mejor diseño de estudio epidemiológico que entrega evidencia de mayor calidad, para buscar la asociación entre una exposición y una enfermedad en una po- blación?

A) Estudio de serie de casos
B) Estudio de series temporales
C) Estudio de casos y controles
D) Estudio de cohorte
E) Estudio clínico no randomizado

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los ensayos clínicos son mejores, pero si no son randomizados, tienen sesgos. Por tanto lo mejor de esas opciones era cohortes, que superan a los de casos y controles.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 123 · 7.01.3.020 · Diseños de investigación e

¿Qué tipo estudio es el más adecuado para determinar el desarrollo de obesidad en un grupo de escolares a lo largo de un determinado tiempo?

A) Estudio de prevalencia
B) Estudio de incidencia
C) Estudio de caso control
D) Estudio de cohortes
E) Ensayo clínico controlado

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La aparición de una enfermedad a lo largo del tiempo es la definición de incidencia. La incidencia se mide con los estudios de incidencia y con los estudios de cohortes, con la diferencia que el estudio de incidencia es simplemente descriptivo y no tiene un grupo de comparación (dice “un grupo de escolares”), mientras que los de cohortes tienen un grupo de control (se separan en expuesto y no expuestos a un factor de riesgo y se siguen en el tiempo, para ver las incidencias de patología). Es una pregunta que induce a error, ya que ambas respuestas son correctas, pero dejaremos como correcta la B, por ser solo un grupo y dar la definición de incidencia en el enunciado.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 47 · 7.01.3.020 · Diseños de investigación e

¿Qué tipo de estudio es el indicado para evaluar la realización de intervenciones focalizadas y solicitar financiamiento para ellas?

A) Estudio de cohortes
B) Estudio de incidencia
C) Estudio de casos y controles
D) Estudio experimental
E) Estudio ecológico

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
[Pregunta disputada] Es una mala pregunta, ya que hay más de un tipo de estudio que se puede utilizar para ello (además que no queda claro a qué tipo de intervenciones focalizadas se refiere). Sin embargo, el estudio de casos y controles suele dar información rápida y barata, que permite identificar los factores de riesgo, para controlarlos. Los ecológicos son baratos, pero abarcan toda la población (no son focalizados).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 7 · 1.07.1.012 · Incontinencia urinaria

Una paciente de 95 años, hipertensa, consulta por un cuadro de enuresis de dos semanas de evolución, sin otros síntomas. Su examen Fsico muestra prolapso genital anterior grado 1 y la prueba de compresión abdominal resulta nega8va. Sus signos vitales se encuentran dentro de los rangos normales y no presenta otras alteraciones en el examen segmentario. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Vejiga neurogénica
B) Vejiga hiperac2va
C) Infección del tracto urinario
D) Incon2nencia de orina de esfuerzo oculta
E) Enuresis primaria

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Aunque la clínica es la clásica de la inconGnencia de urgencia (por vejiga inestable), la corta evolución (2 semanas) debe hacer sospechar primero una causa reversible. En adultos mayores, la ITU puede manifestarse de forma aVpica, sin disuria ni fiebre, siendo la inconGnencia de nueva aparición un signo frecuente. Se debe recordar, además, que en toda inconGnencia de orina el primer paso es descartar ITU.

EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 131 · 1.07.1.012 · Incontinencia urinaria

Mujer de 85 años tiene el diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia. Su examen ginecológico es normal, y trae un examen de orina, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el mas indicado para el manejo de esta paciente?

A) Amitriptilina
B) Imipramina
C) Oxibutinina
D) Tolterodina
E) Trazodona

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los anticolinérgicos son los fármacos de elección para la IOU (en particular la oxibutinina y la tolterodina). Los tricíclicos están absolutamente contraindicados en los adultos mayores, dado los efectos adversos potencialmente graves. La mayoría de los estudios no muestran diferencias entre ambas, pero la tolterodina tiene menos efectos adversos (menos boca seca). Hoy hay algunos anticolinérgicos más nuevos y seguros: fesoterodina y solifenacina (que serían de segunda línea, por ser más caros).

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 126 · 7.01.3.036 · Organización actual del si

Una empresa extranjera dedicada a otorgar prestaciones en salud decide iniciar sus operaciones en Chile, para lo cual solicita saber cuál es la ins8tución que actúa como laboratorio de referencia para todos los laboratorios, tanto públicos como privados, en el país. ¿Cuál es la respuesta correcta?

A) Central fíacional de Abastecimiento
B) Ins2tuto de Salud Pública
C) Superintendencia de Salud
D) Servicio Médico Legal
E) Secretaría Regional Ministerial de Salud

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El InsGtuto de Salud Pública Gene varias funciones. Es un institución cienVfico técnica cuyas principales funciones (de acuerdo a su normativa) son: actuar como laboratorio nacional y de referencia; supervisar laboratorios de exámenes médicos y de producción de medicamentos; autorizar, registrar y fiscalizar medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos; realizar vigilancia sanitaria y epidemiológica, con pruebas de laboratorio sobre infecciones (ej. Western blot VIH, vigilancia virus respiratorios, Gpificación de infecciones graves); y desarrollar investigación y control en salud ambiental y ocupacional.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 129 · 7.01.3.036 · Organización actual del si

¿Cuál de las siguientes instituciones es la encargada de supervisar el funcionamiento del sistema de salud público y privado en Chile, fiscalizar a FONASA y a las instituciones previsionales de salud, y velar por el cumplimiento de las garantías GES?

A) Instituto de Salud Pública
B) Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud
C) Ministerio de Salud, por medio de la Subsecretaría de Salud Pública
D) Superintendencia de Salud
E) Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Superintendencia de Salud: La Superintendencia de Salud es el organismo encargado de las funciones mencionadas en la pregunta.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 66 · 7.01.3.036 · Organización actual del si

La Subsecretaría de Redes Asistenciales delega sus funciones a nivel territorial en:

A) La Superintendencia de Salud
B) La Secretaría Regional Ministerial de Salud
C) La Dirección del Servicio de Salud
D) El hospital autogestionado
E) La Dirección de Salud Comunal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La Subsecretaría de Redes Asistenciales es parte del Minsal, que delega sus funciones en la Seremi de Salud, a nivel regional.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 161 7.01.3.036 · Organización actual del si

¿Qué institución da la autorización sanitaria para el funcionamiento de laborato- rio y clínicas?

A) Superintendencia de Salud
B) Secretaría Regional Ministerial de Salud
C) Corporaciones Municipales de Salud
D) Dirección del Servicio de Salud
E) Superintendencia de Seguridad Social

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Secretaría Regional Ministerial de Salud). La Seremi de Salud es la autoridad sanitaria y por tanto quien da las autoriza- cions sanitarias.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 170 7.01.3.026 · Causalidad y sesgos

Un problema de los estudios de casos y controles es que, al ser retrospectivo, las personas evaluadas olvidan las situaciones a las que estuvieron expuestos. Aquello produce un tipo de error sistemático, que corresponde a un:

A) Error de clasificación diferencial
B) Sesgo de selección
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de información
E) Error de clasificación no diferencial

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
El sesgo de memoria es un tipo de sesgo de información o medida, que afecta al evaluado. Los errores de clasificación son aquellos...

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 68 7.01.3.026 · Causalidad y sesgos

Según los criterios de causalidad de Hills Bradtford, ¿cuál es requisito para establecer una asociación causal?

A) Fuerza de asociación
B) Plausibilidad biológica
C) Respuesta dosis dependiente
D) Secuencia temporal
E) Asociación estadística

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Si no se da que la causa aparece antes que el efecto, definitivamente no puede ser la causa. No deberían preguntar filosofía en el Eunacom.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 75 7.01.3.026 · Causalidad y sesgos

El uso del enmascaramiento (doble ciego controlado) como medida en estudios epidemiológicos tiene como objetivo:

A) Disminuir el sesgo de información
B) Disminuir sesgo de selección (es de información, en específico los subtipos del evaluador y el evaluado, sesgo de selección sería realizar un estudio excluyendo de la muestra de estudio una población especifica y relevante)
C) Darle mayor valor al estudio
D) Disminuir el error aleatorio
E) Hemograma y VHS

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Disminuir el sesgo de información). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Disminuir sesgo de selección (es de informaci, Darle mayor valor al estudio) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 94 7.01.3.026 · Causalidad y sesgos

En un estudio se realiza la validación y estandarización de las encuestas a aplicar. ¿Qué tipo de sesgo se busca evitar?

A) Sesgo de memoria
B) Sesgo de información
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de notificación
E) Sesgo del entrevistador

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los sesgos de información o sesgos de medida son aquellos en los que la información obtenida está sesgada. En este caso se trata de un sesgo del instrumento de medición. Ver resumen de SP o una película de terror (son iguales).

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 70 7.01.3.026 · Causalidad y sesgos

¿Qué tipo de sesgo se trata de evitar, al validar previamente los cuestionarios en un estudio?

A) Sesgo de memoria
B) Sesgo de información
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de selección
E) Sesgo del entrevistador

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los sesgos de información o medida se previenen con el doble ciego y con instrumentos de medición validados y calibrados.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 32 7.01.3.026 · Causalidad y sesgos

Se realiza un estudio en el que se busca la asociación entre el uso de anticoncepti- vos orales y el desarrollo de hipertensión arterial, el cual concluye que existe mayor desarrollo de hipertensión arterial en pacientes que utilizaban anticonceptivos orales. Sin embargo, las pacientes que recibieron anticonceptivos orales fueron controladas 3 veces más que las pacientes que no recibieron esta intervención. ¿Qué sesgo se encuen- tra presente en el estudio descrito?

A) Sesgo de selección
B) Sesgo de notificación
C) Sesgo de exclusión
D) Sesgo de vigilancia
E) Sesgo del evaluador

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Sesgo de vigilancia). Es un clásico sesgo de vigilancia (se detectan más problemas en el grupo más vigilado).. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 73 7.01.3.026 · Causalidad y sesgos

La erradicación del Helicobacter pylori reduce significativamente la recidiva de la úlcera gastroduodenal, en comparación a aquellos casos en que no se erradica. Este es uno de los principales argumentos para afirmar la relación causal entre esta bacteria y dicha patología. ¿A qué criterio de causalidad de Bradtford Hills corresponde?

A) Asociación
B) Relación dosis efecto
C) Plausibilidad biológica
D) Cesación de la exposición
E) Congruencia con el conocimiento científico existente

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Cesación de la exposición). De las opciones es la única aceptable.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 69 7.01.3.015 · Usos de la epidemiología e

¿Cuál es el mejor indicador para determinar el éxito de una campaña de vacunación?

A) Tasa de incidencia
B) Tasa de prevalencia
C) Tasa de hospitalizaciones
D) Tasa de mortalidad
E) Tasa de cobertura de vacunación

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Tasa de incidencia). La tasa de incidencia debería bajar, si la campaña es exitosa.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 6 7.01.3.032 · Estrategias de control de

¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo?

A) Tasa de incidencia de cáncer de mama
B) Tasa de prevalencia de cáncer de mama
C) Tasa de letalidad de cáncer de mama
D) Tasa de mortalidad de cáncer de mama
E) Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje del cáncer de mama

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Las medidas de tamizaje de los distintos cánceres buscan reducir la mortalidad. No disminuyen la incidencia, ya que no son medidas

---

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 101 7.01.3.032 · Estrategias de control de

Un paciente de 65 años, fumador de 20 paquetes-año, fuma el primer cigarrillo al despertarse y fuma en lugares donde está prohibido y a pesar de resfriarse. Consulta porque ha pensado en suspender el tabaco. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Entrevista motivacional
B) Bupropión
C) Parche de nicotina
D) Diazepam
E) Vareniclina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una mala pregunta, ya que lo más correcto es indicar psicoterapia cognitivo conductual (es lo más importante y asumo que se incluye dentro de la entrevista motivacional), sin embargo, también se deben indicar fármacos de apoyo, como la B, C y E.

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 76 7.01.3.032 · Estrategias de control de

¿Cuál de las siguientes exposiciones laborales se asocian al desarrollo de cáncer de vejiga?

A) Solventes
B) Mercurio
C) Anilinas
D) Pesticidas
E) Plomo

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Anilinas). Pésima pregunta.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Solventes, Mercurio) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 69 **1.07.1.003 · Demencia**

Un hombre de 78 años, acude a control, ya que su esposa refiere que, desde hace algunos meses ha presentado movimientos involuntarios mientras se está quedando dormido, presentando también problemas de memoria que han ido en aumento y se han asociado a algunas ideas paranoides. Además, ha estado más apático y desmotivado, aunque sus dificultades han tenido un curso fluctuante, pero con tendencia a empeorar. En el examen físico se aprecia colaborador y amable, con cierto grado de rigidez en extremidades superiores e inferiores, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Parkinson
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Hidrocefalia normotensiva
D) Síndrome confusional agudo
E) Demencia por cuerpos de Lewy

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Enfermedad de Alzheimer** (opción **B**). Esta clase cubre la anemia ferropénica, la anemia más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 34 **1.07.1.003 · Demencia**

Un paciente de 65 años, es traído por su señora, dado que presenta dificultades en sus actividades de la vida diaria. Ella refiere que ha estado repetitivo con errores en el manejo del dinero, así como dificultad para realizar actividades que normalmente rea- lizaba sin problemas. El niega estos síntomas. Al examen físico presenta frecuencia car- diaca 68 latidos por minutos, con presión arterial de 130/85 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario, ni signos de focalidad neurológica. El diagnóstico más probable es:

A) Delirium
B) Demencia vascular
C) Depresión del adulto mayor
D) Demencia tipo Alzheimer
E) Demencia por cuerpos de Lewi

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Parece una demencia inicial y dado que no tiene indicadores de otra patología, lo más probable es que sea una demencia tipo Alzheimer.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 15 **1.07.1.003 · Demencia**

Una paciente de 86 años, viuda desde hace 2 años, consulta porque ha notado olvidos frecuentes de eventos recientes en el último año, que han aumentado en los últimos dos meses. Presenta temor de estar iniciando una enfermedad de Alzheimer. En la evaluación se muestra atenta, orientada, cooperadora. Además, puede invertir series y recuerda 2 de 3 palabras que se le comunican durante la entrevista. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Duelo patológico
C) Trastorno neurocognitivo menor
D) Accidente vascular encefálico
E) Delirium

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno Neurocognitivo Menor: Este trastorno se caracteriza por un deterioro cognitivo inicial en adultos mayores sin llegar a cumplir los criterios de demencia . El manejo se centra en mantener la autonomía del paciente y monitorear la posible evolución a demencia en los próximos años.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 15 **7.01.3.040 · Beneficios de la seguridad**

Una paciente de 36 años presenta un trabajo de parto prematuro a las 28 semanas con resultado de mor8nato de 800 g y anencefalia. Según la norma8va vigente, ¿por cuánto 8empo debe recibir descanso laboral?

A) 7 días
B) 10 días
C) 6 semanas
D) 12 semanas
E) 24 semanas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene derecho al descanso “postnatal” (12 semanas), cuyo objetivo es la recuperación de la madre tras el parto. No Gene derecho al descanso postnatal parental (12 semanas más, que inician al terminar el postnatal), cuyo objetivo es el cuidado del bebé y, por tanto, requiere que esté vivo (no está explícito en la ley, pero sí en la jurisprudencia y dictámenes de la Suseso y Dirección del Trabajo). Se financia con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de CesanVa y lo paga Fonasa o la Isapre. Además, vale la pena recordar un tema disGnto: la "Ley Dominga" que aplica en caso de la muerte de un ser querido del trabajador. En este caso hay un permiso remunerado por el empleador, quien lo financia, ya que no descuenta los días no trabajados. En este caso, no se emite una licencia médica propiamente tal, sino que se usa el cerGficado de defunción (o de defunción fetal, que es emiGdo por el médico). El número de días varía según qué ser querido muere: 10 días para hijo nacido vivo (aplica a ambos padres); 7 días en caso de abortos y muertes antenatales (también a ambos padres); 7 días en caso de muerte del cónyuge o conviviente civil; y 3 días si muere alguno de los padres del trabajador.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 6 **7.01.3.040 · Beneficios de la seguridad**

Una embarazada de 28 semanas, afiliada a Isapre, presenta síntomas de aborto y se emite licencia por 2 semanas. ¿Quién debe pagarle la licencia?

A) El empleador directamente
B) FONASA
C) Isapre
D) Mutualidad de seguridad
E) Caja de compensación

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Isapre). Isapre. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (El empleador directamente, FONASA) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 102 **7.01.3.040 · Beneficios de la seguridad**

Paciente de 45 años, trabajador de una fábrica textil, sufre un accidente, resultado con atrición del brazo, en una de las máquinas, mientras se encontraba trabajando. ¿Quién cubre los gastos médicos de este paciente?

A) El empleador
B) 50% por parte de FONASA y 50% por parte del trabajador
C) La institución de Salud Previsional
D) La Mutual de Seguridad
E) El Estado

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Los accidentes laborales son cubiertos por las mutuales, ya que ellas administran el fondo del seguro de este tipo de accidentes.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 103 · 7.01.3.040 · Beneficios de la seguridad

Una paciente de 31 años, cursando un embarazo de 28 semanas, presenta síntomas de parto prematuro, por lo que se le deja licencia médica por 2 semanas. Está afiliada a una Isapre y a una Mutual. ¿Qué institución es la encargada del financiamiento de esta licencia?

A) Fondo Nacional de Salud (Fonasa)
B) Institución de Salud Previsional (Isapre)
C) Caja de Compensación
D) Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin)
E) Fondo Único de Prestaciones Familiares, con cargo Estatal

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **B** (Institución de Salud Previsional (Isapre)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Caja de Compensación) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 8 · 7.01.3.025 · Concepto de estudios ecoló

En un estudio se realiza medición de los niveles plasmáticos de pesticidas a personas de distintos países, obteniéndose los niveles promedios para la población de cada país. Luego, se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer de cada país. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

A) Observacional
B) Cohortes
C) Experimental
D) Ecológico
E) De contraste de hipótesis

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un estudio ecológico clásico, que usa variables agregadas (ej. promedio de niveles plasmáticos y tasas de mortalidad) comparando distintas poblaciones.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 45 · 7.01.3.025 · Concepto de estudios ecoló

En un estudio se realiza la medición de los niveles plasmáticos promedio de pesticidas, en la población de distintos países y se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

A) Ecológico
B) Cohortes
C) Caso control
D) Observacional
E) Experimental

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es un estudio ecológico clásico, sin embargo, vale la pena mencionar que también es un estudio de tipo observacional (ya que no es experimental).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 65 · 7.01.3.025 · Concepto de estudios ecoló

En un estudio se analiza la tasa de infarto al miocardio en distintos países según el consumo de grasas saturadas, sin seguir a individuos en el tiempo. ¿Qué tipo de diseño epidemiológico corresponde?

A) Estudio ecológico
B) Estudio de cohorte
C) Estudio de casos y controles
D) Ensayo clínico aleatorizado
E) Estudio transversal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Estudio ecológico: la unidad de análisis son poblaciones o grupos (no individuos). Se comparan tasas de enfermedad entre diferentes grupos. Limitación principal: falacia ecológica (no se puede inferir asociación individual).

EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 4 · 7.01.3.042 · Planificación y programaci

En gestión de salud, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación?

A) La planificación se refiere a objetivos y recursos específicos, mientras que la programación es global
B) La planificación es a largo plazo, mientras que la programación es anual
C) La programación, a diferencia de la planificación, debe ser concordante con la misión y la visión de la institución
D) La planificación se basa en lo determinado con la programación
E) La planificación se relaciona a los costes y recursos de actividades concretas y la programación se relaciona con el presupuesto general del proyecto

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La planificación es a largo plazo y se refiere a la estrategia global de la institución. La programación se basa en la planificación y fija las actividades a realizarse y los recursos necesarios en el corto plazo, generalmente anual, mensual y semanalmente. La A, D y E están al revés los conceptos de planificación y programación. Ambas deben ser compatibles con la misión (la forma en que satisface una necesidad) y la visión (objetivo a larga plazo de la institución), ya que estas regulan la planificación, la que, a su vez, determina la programación.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 135 · 7.01.3.042 · Planificación y programaci

¿Cuál es el mejor indicador para determinar la contratación del recurso humano obstétrico en un servicio de salud?

A) La población beneficiaria del servicio
B) La tasa de fecundidad en la población
C) Los recién nacidos por residencia
D) El número de partos históricos en el plantel
E) La tasa de fertilidad de la población

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La alternativa correcta es la **D** (El número de partos históricos en el plantel). Si hay más partos en el hospital, se necestan más obstetras y matronas.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 136 7.01.3.010 · Etapas del diagnóstico de

La última fase del diagnóstico de salud participativo es:

A) La comprobación de los problemas de salud, referidos por la comunidad
B) La determinación de estadísticas y datos objetivos y completos
C) La determinación de la prevalencia de las patologías más importantes de la comunidad
D) La definición de estrategias de intervención, priorizadas
E) Realización de estudios experimentales

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Lo umportante es que se interactúa con la comunidad y se van escogiendo las patologías y factores de riesgo más importantes para la salud pública y para la comunidad, de manera de intevernir sobre ellas, haciendo una priorizació previamente.

EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 82 1.07.1.007 · Escaras o úlceras por pres

Un paciente de 86 años, con antecedente de un accidente vascular encefálico, hace un año, seculado con un síndrome de inmovilidad y marcada dependencia, presenta una lesión en la zona sacra. Al examen físico, presenta eritema en la zona sacra, sin solución de continuidad de la piel. El tratamiento más adecuado es:

A) Aseo con hidrogel
B) Colchón antiescaras
C) Antibióticos
D) Resolución quirúrgica
E) Cambios de posición frecuentes

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una úlcera por presión en etapa I (sin solución de continuidad de la piel), por lo que el tratamiento consiste en cambios de posición frecuentes. El colchón antiescaras no reemplaza los cambios de posición, pero sí estaría indicado también.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 162 1.07.1.007 · Escaras o úlceras por pres

Un paciente de 78 años, postrado, presenta una lesión en la zona sacra, de 12 cm de diámetro, que afecta la piel y dermis y que en una zona deja entrever el músculo. Tiene necrosis en el borde y mal olor. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Antibióticos tópicos
B) Debridamiento químico
C) Curaciones con suero fisiológico
D) Colgajo
E) Cámara hiperbárica

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Tiene una escara sacra grado l!l, por lo que, además de los cambios de posición, se debe realizar el debridamiento químico para eliminar el área necrótica y de mal olor y facilitar la curación. No se ven signos de celulitis, como para indicar antibióticos.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 12 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

En una zona rural del país se recibe una gran can8dad de migrantes, principalmente personas jóvenes y sanas. Desde el punto de vista de la ges8ón en salud pública para dicha zona, ¿qué medida debe priorizarse?

A) Aumentar los recursos para el programa de enfermedades crónicas
B) Aumentar los recursos para los programas de atención materno-infan2l
C) Reforzar los programas de saneamiento básico
D) Realizar empadronamiento de los migrantes
E) Aumentar el número de camas hospitalarias

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La inmigración de personas sanas y en edad férGl (fenómeno que ha ocurrido en Chile en la úlGma década), produce aumento de la tasa de natalidad, por lo que es necesario destinar mayores recursos a la atención materno infantil. La población usuaria sí aumenta, por lo que muchas veces sí es necesario aumentar la capacidad de atención (ej. personal o camas), pero, al ser sanas, suele ser menor este impacto. El saneamiento básico es importante en las pobaciónes con pirámides de poblacionales jóvenes, ya que, suelen ser países pobres, en los que los esfuerzos de salud se concentran en saneamiento básico, prevención de infecciones y atención materno infantil, pero no se debe confundir con este otro fenómeno, en que la inmigración suele producirse hacia un destino que ya Gene una infraestructura aceptable. El empadronamiento es una acción administrativa que puede ser úGl en otros ámbitos, pero no es tan relevante respecto de la gestión de salud. Los programa de crónicos, por el contrario, se deben reforzar ante el envejecimiento de la población.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 13 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

Una localidad de la zona norte del país experimenta un aumento significa8vo de migrantes debido a un programa de incen8vos laborales y subsidios económicos, el cual exige una permanencia mínima de 5 años y atrae principalmente a parejas jóvenes y niños. ¿Cuál de los siguientes cambios demográficos es esperable?

A) Aumento de la expecta2va de vida de la población
B) Aumento de la tasa bruta de mortalidad
C) Aumento de la tasa bruta de natalidad
D) Aumento de la tasa de mortalidad infan2l
E) Aumento de la prevalencia de cánceres ginecológicos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pregunta muy similar a la anterior y aplica la misma lógica, con más personas en edad férGl, por lo que aumentará la tasa de natalidad. La expectativa de vida y la tasa de mortalidad infantil no dependen de la edad de la población, sino de las condiciones generales del país o ciudad en la que están: mientras más rico un país, mayor la expectativa de vida y menor la mortalidad infantil. Los cánceres ginecológicos suelen ser más frecuentes en edad avanzada (ovario y endometrio), aunque el de cuello uterino puede verse en edades más jóvenes.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 124 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

Un país presenta la siguiente pirámide poblacional: ¿En qué tipo de medidas se deben focalizar las intervenciones de salud pública?

A) Prevenir y tratar oportunamente el cáncer
B) Prevención del consumo de drogas, cigarrillo y alcohol
C) Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación
D) Fomentar la actividad física y prevenir el sedentarismo y la obesidad
E) Detección y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **C** (Planificación familiar, prevención de la desnutrición, saneamiento básico y vacunación). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 153 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

¿Cuál de los siguientes indicadores es una variable de la demografía dinámica?

A) Tasa de fecundidad
B) Índice de población urbana / rural
C) Tasa de masculinidad
D) Distribución etárea
E) Tasa de mortalidad infantil

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Tasa de fecundidad). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Índice de población urbana / rural, Tasa de masculinidad) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 1 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

¿Cuál corresponde a un indicador de demografía dinámica?

A) Tasa de mortalidad infantil
B) Tasa de prevalencia de diabetes
C) Índice de masa corporal poblacional
D) Tasa de alfabetismo
E) Porcentaje de cobertura vacunal

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Tasa de mortalidad infantil** (opción **A**). Tasa de mortalidad infantil. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 138 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

Si aumenta la velocidad de envejecimiento en la población que pasara en temas de salud publica:

A) Aumento de cobertura de adultos mayores en APS
B) Aumento de personas con fragilidad
C) Aumento en la variabilidad de morbilidad o mortalidad
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Aumento de personas con fragilidad). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Aumento de cobertura de adultos mayores en AP, Aumento en la variabilidad de morbilidad o mo) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 7 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

Se tiene una población con pirámide poblacional de base ancha y vértice angosto. ¿En qué tipo de medidas debe enfocarse la salud pública?

A) Manejo de enfermedades crónicas y oncológicas
B) Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación
C) Rehabilitación y cuidados paliativos
D) Prevención cardiovascular en adultos mayores
E) Tamizaje de cáncer en adultos

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **B** (Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación). Planificación familiar, saneamiento básico y vacunación. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 4 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

Una población presenta la siguiente pirámide poblacional: ¿En qué tipo de medidas deben enfocarse sus políticas de salud pública?

A) Prevención y manejo de patologías crónicas no transmisibles
B) Prevención y tratamiento de patologías de salud mental
C) Saneamiento básico, planificación familiar y vacunación
D) Prevención de tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas
E) Promoción de actividad física y alimentación saludable

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Es una pirámide joven, por lo que debe enfocarse en salud maternoinfantil, nutrición y control de patologías infecciosas. Todas las demás opciones son importantes en las pirámides de transición y envejecidas, en especial el manejo y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 117 7.01.3.007 · Demografía y salud pública

Un gráfico muestra la distribución de causas de muerte en Chile: las enfermedades cardiovasculares y el cáncer representan el 60% de las muertes, mientras las enfermedades infecciosas son <5%. ¿A qué concepto corresponde este patrón?

A) Transición epidemiológica
B) Transición demográfica
C) Transición nutricional
D) Envejecimiento poblacional
E) Brecha epidemiológica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Transición epidemiológica: cambio en el patrón de mortalidad desde enfermedades infecciosas y perinatales hacia enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, cáncer). Asociado a desarrollo económico y envejecimiento.

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 12 · 1.07.2.004 · Agitación y agresividad

Mujer de 78 años con diagnóstico de Alzheimer moderado. Presenta agitación nocturna severa, intentos de golpear a cuidadores y deambulación sin propósito, que no cede con medidas no farmacológicas. ¿Cuál es el fármaco más apropiado?

A) Donepezilo
B) Haloperidol en dosis alta
C) Risperidona 0.5 mg nocturno
D) Memantina
E) Quetiapina 25 mg nocturno

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Trastorno conductual en Alzheimer: quetiapina a dosis bajas (12.5-25 mg) es preferida por su mejor perfil de seguridad en el adulto mayor (menos efectos extrapiramidales que haloperidol/risperidona). Usar solo si medidas no farmacológicas fallan.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 128 · 1.07.2.004 · Agitación y agresividad

Adulto mayor con Alzheimer con agitación nocturna e insomnio, tranquilo durante el día. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Risperidona 8-10 gotas en la noche
B) Zolpidem 10 mg al acostarse
C) Haloperidol 5 mg IM nocturno
D) Clonazepam 0,5 mg oral en la noche
E) Melatonina 3 mg al acostarse

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Risperidona 8-10 gotas en la noche** (opción **A**). Risperidona 8-10 gotas en la noche. Tratamiento urgente: plasmaféresis (recambio de plasma) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 9 · 1.07.2.004 · Agitación y agresividad

Un paciente de 81 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, presenta mayor desorientación desde hace dos semanas. Además, hace 4 días comienza con incontinencia urinaria y mayor confusión, con dificultades para dormir y algún grado de agresividad y agitación, especialmente en la noche. Además, de solicitar un hemograma, sedimento de orina y urocultivo, ¿cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su cuadro actual?

A) Contención física
B) Risperidona 8 a 10 gotas vía oral cada noche
C) Haloperidol 5 mg intramuscular cada 12 horas
D) Diazepam 3 mg vía oral, en la noche
E) Melatonina oral, 3 mg en la noche

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Diazepam 3 mg vía oral, en la noche** (opción **D**). Tratamiento urgente: plasmaféresis (recambio de plasma) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 166 · 7.01.3.039 · Concepto y descripción de

¿Cuál de los siguientes corresponde a un centro de atención secundaria?

A) CESFAM
B) CECOSF
C) Posta de salud rural
D) Hospital comunitario de familia
E) COSAM

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **COSAM** (opción **E**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (CESFAM, CECOSF) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 31 · 7.01.3.039 · Concepto y descripción de

¿Cuál de las siguientes instituciones corresponde a un centro de salud secundaria?

A) Posta de Salud Rural
B) CESFAM (Centro de Salud Familiar)
C) COSAM (Centro de Salud Mental)
D) CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar)
E) Hospital comunitario

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Posta de Salud Rural** (opción **A**). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 52 · 7.01.3.051 · Certificado de defunción,

Si detecto una infección que debe tener notificación obligatoria inmediata. Conducta:

A) Avisar al delegado de epidemiología
B) Notificar inmediatamente a la SEREMI
C) Reportar en plataforma digital durante las primeras 24 hrs
D) Staphylococcus aureus
E) Streptococcus pneumoniae

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Notificar inmediatamente a la SEREMI** (opción **B**). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 4 **7.01.3.051 · Certificado de defunción,**

Un paciente con antecedente de cáncer de próstata sufre un TEP, falla respiratoria, paro cardíaco y muerte. ¿Cuál es la causa inmediata de muerte en el certificado de defunción?

A) Cáncer de próstata
B) Tromboembolismo pulmonar
C) Paro cardíaco
D) Falla respiratoria
E) Trombosis venosa profunda

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Falla respiratoria). Falla respiratoria. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Cáncer de próstata, Tromboembolismo pulmonar) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 145 **7.01.3.051 · Certificado de defunción,**

Un paciente de 80 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia, presenta deterioro súbito del estado respiratorio, evolucionando con taquicardia y desaturación arterial. Se solicita angioTAC, que demuestra un tromboembolismo pulmonar derecho, por lo que se inicia terapia anticoagulante, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, cayendo en insuficiencia respiratoria, colapso circulatorio y, finalmente, ausencia de pulso y respiración, por lo que se realiza reanimación avanzada, con múltiples desfibrilaciones y adrenalina, sin respuesta, por lo que se declara la muerte. ¿Cuál de las siguientes debe ser la causa de muerte inmediata en el certificado de defunción?

A) Cáncer de próstata
B) Insuficiencia respiratoria aguda
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Falla multiorgánica
E) Fibrilación ventricular

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Tromboembolismo pulmonar** (opción **C**). El TEP masivo con compromiso hemodinámico tiene estudio y tratamiento completamente diferentes De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 5 **7.01.3.054 · Otorgamiento, uso y sancio**

¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde a una licencia médica tipo I (enfermedad o accidente común)?

A) Amigdalitis aguda
B) Accidente laboral con fractura
C) Enfermedad profesional por ruido
D) Reposo por embarazo de alto riesgo
E) Licencia por maternidad

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Diagnóstico: **Amigdalitis aguda** (opción **A**). Amigdalitis aguda. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 174 **7.01.3.054 · Otorgamiento, uso y sancio**

¿En cuál de los siguientes casos se debe indicar una licencia médica tipo 1, por enfermedad o accidente común?

A) Lumbago mecánica en trabajador de la construcción
B) Invalidez por accidente vascular encefálico
C) Fractura de rodilla en trayecto en bicicleta del trabajo a la casa
D) Amigdalitis bacteriana
E) Hospitalización por preclamsia a las 30 semanas

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **D** (Amigdalitis bacteriana). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Lumbago mecánica en trabajador de la construc, Invalidez por accidente vascular encefálico) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 53 **7.01.3.054 · Otorgamiento, uso y sancio**

Institución encargada de que lo medico legal cumpla con la seguridad social algo asi

A) Compin
B) SIS
C) SUSESO
D) Medicina legal
E) Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
La alternativa correcta es la **A** (Compin). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (SIS, SUSESO) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 63 **1.07.1.001 · Caídas**

Viejito q consulta x miedo a caídas, caída hace 10 meses sin lesiones actualmente. Se constata atrofia leve de cuádriceps. Test tiempo en pararse y caminar en 14 (VN: <14 seg) test de cuanto dura parado en 1 pie de 3 seg. Conducta:

A) Ejercicios multicomponente
B) Fortalecimiento cuadriceps c. Caminata diaria
D) Bastón
E) Ejercicio aeróbico
E) Observación clínica

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**
Conducta / Tratamiento indicado: **Ejercicios multicomponente** (opción **A**). El estudio de la hematuria sigue un orden secuencial: anamnesis y examen físico, sedimento más urocultivo, imagen, y cistoscopía De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 46 7.01.3.056 · Conocimiento de los derech

Se pretende realizar un estudio en adolescentes de 16 años, que estudian en colegios del sector público. ¿Quién debe firmar el documento de consentimiento informado para autorizar la participación de estos pacientes?

A) El alumno
B) El director del establecimiento
C) Cualquier pariente mayor de edad
D) El apoderado
E) El encargado de salud y bienestar estudiantil del establecimiento

Respuesta: D **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Consentimiento Informado: El consentimiento informado se aborda en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y en la ley sobre investigación científica en seres humanos en Chile. En adultos, el consentimiento puede ser verbal, pero debe ser informado y voluntario. Para que sea informado, se debe proporcionar toda la información necesaria, incluyendo riesgos, procedimientos y alternativas, antes de obtener el consentimiento. En menores de edad, los padres o tutores legales deben dar su consentimiento, pero los niños tienen derecho a ser escuchados según su edad y madurez. En investigación, se requiere consentimiento previo, expreso, libre e informado del participante, o el consentimiento de la persona que deba suplir su voluntad según la ley, que en el caso de menores son los padres o tutores legales.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 167 7.01.3.052 · Ejercicio profesional: mar

¿Cuál es el cuerpo normativo que regula el ejercicio de la profesión médica en Chile?

A) Constitución Política de la República
B) Código del Colegio Médico de Chile
C) Ley que crea el Ministerio de Salud
D) Ley de Derechos y Deberes del Paciente
E) Código Sanitario

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Alcance del Código Sanitario: El Código Sanitario de Chile regula el ejercicio de las profesiones de la salud, las medidas de prevención y control de enfermedades transmisibles, la protección del medio ambiente en materia sanitaria, los medicamentos y productos farmacéuticos, y las condiciones para el funcionamiento de hospitales, clínicas y salas de procedimiento. También establece la fiscalización por parte de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 64 7.01.3.052 · Ejercicio profesional: mar

Durante una evaluación de calidad en un hospital se constata que un anestesista, en conjunto con un técnico en anestesia, utilizan tres pabellones de manera simultánea. El informe del hospital comunica que aquella es la práctica habitual. ¿A qué tipo de práctica corresponde este caso?

A) Error médico
B) Impericia
C) Negligencia médica
D) Eficiencia
E) Imprudencia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Imprudencia médica: En el contexto médico, la imprudencia se define como la realización de acciones temerarias que aumentan innecesariamente el riesgo de complicaciones y problemas para los pacientes. La impericia se refiere a la falta de conocimientos o habilidades necesarios para realizar una actividad o procedimiento médico. La negligencia es la falta del debido cuidado, generalmente por omisión. La eficiencia, por otro lado, busca optimizar el uso de los recursos, pero siempre debe hacerse de manera diligente y sin poner en riesgo la salud del paciente.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 63 7.01.3.052 · Ejercicio profesional: mar

Durante una evaluación de calidad en un hospital se constata que un anestesista, en conjunto con un técnico en anestesia, utilizan tres pabellones de manera simultánea. El informe del hospital comunica que aquella es la práctica habitual. ¿A qué tipo de práctica corresponde este caso?

A) Error médico
B) Impericia
C) Negligencia médica
D) Eficiencia
E) Imprudencia

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Imprudencia médica: La imprudencia se define como la realización de acciones temerarias que aumentan innecesariamente el riesgo de complicaciones. La impericia es falta de conocimientos o habilidades. La negligencia es falta del debido cuidado por omisión. Usar 3 pabellones simultáneamente con un solo anestesista es temerario.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 97 1.07.3.005 · Envejecimiento saludable y

¿Cuál de las siguientes medidas se considera más adecuada para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores entre 60 y 75 años?

A) Higiene del sueño
B) Terapia de relajación
C) Ejercicio físico y estudio activo
D) Actividades manuales frecuentes
E) Administración oral de vitamina C y folatos

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Mantenimiento de la Salud en Adultos Mayores: El ejercicio físico y el estudio activo son las medidas que han demostrado mayor impacto en mantener la salud física, cognitiva y mental de los adultos mayores..

EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 143 1.07.1.008 · Fragilidad

Hombre de 78 años con pérdida de masa muscular, fuerza de prensión <16 kg y velocidad de marcha 0.7 m/s. ¿Cuál es el diagnóstico y la intervención más eficaz?

A) Sarcopenia: ejercicio de resistencia progresivo + aporte proteico adecuado (1.2-1.5 g/kg/día)
B) Desnutrición: solo suplementos nutricionales orales
C) Depresión en adulto mayor: antidepresivos
D) Osteoporosis: bifosfonatos
E) Hipotiroidismo: levotiroxina

Respuesta: A **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Sarcopenia (masa + fuerza muscular reducidas + velocidad de marcha lenta): intervención más efectiva = ejercicio de resistencia progresivo + ingesta proteica aumentada. No hay fármaco aprobado de primera línea.

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 152 1.07.1.008 · Fragilidad

Una paciente de 70 años sufrió una caída a nivel hace un mes, que resultó en una fractura de tobillo derecho. Al examen físico, se encuentra un diámetro de pierna de 33 cm (valor normal: mayor a 31 cm), una prueba de unipedestación con un tiempo de 2 segundos (valor normal: mayor a 5 segundos) y una velocidad de marcha de 0.4 m/s (valor normal: mayor a 0.8 m/s). La densitometría ósea muestra un T-score de -1.9 en la columna lumbar y -2.1 en las caderas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Osteoporosis
B) Sarcopenia
C) Osteosarcopenia
D) Fragilidad
E) Alto riesgo de caídas

Respuesta: C **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Osteopenia, Osteoporosis y Sarcopenia: Osteopenia: T-score menor o igual a -1. Osteoporosis: T-score menor o igual a -2.5 (no en este caso). Sarcopenia: Se diagnostica con base en atrofia muscular y/o debilidad muscular, evidenciada en este caso por alteraciones en la velocidad de la marcha y en el test de unipedestación.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 25 1.07.5.002 · Valoración cognitiva

Una paciente de 84 años es traída por su hija debido a que presenta olvidos frecuentes. Su acompañante refiere que la paciente ha olvidado recetas, ya no cocina como antes y 8ene dificultades crecientes en el manejo del dinero. Recientemente se desorientó en la calle, por lo que requirió ayuda para volver a casa. Tiene escolaridad incompleta hasta sexto básico. Al examen se observa orientada, cooperadora y sin alteraciones neurológicas. ¿Cuál es el examen más adecuado para la evaluación inicial de esta paciente?

A) Test de Montreal Cogni2ve Assessment (MOCA)
B) Mini-Mental State Examina2on (MMSE)
C) Prueba de Confusion Assessment Method (CAM)
D) Test del reloj
E) Prueba de memorización de tres palabras

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La sospecha es una demencia, por lo que la prueba de elección es el test Mini-Mental (MMSE). El test del reloj puede ser úGl y es una prueba rápida, pero ante la sospecha clínica, se prefiere el MMSE. El test MOCA también sirve, pero es mucho más exigente y, por lo tanto, más sensible, pero menos específico y su mayor uGlidad suele ser en pacientes con MMSE normal, en que se busca deterioro cogni<vo inicial. En cambio, el CAM y la memorización de 3 palabras, sirven más para el delirium, que es un cuadro agudo en que se afecta principalmente la atención y el estado de conciencia.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 118 7.01.3.046 · Evaluación y control: conc

En un programa de detección precoz de cáncer de mama, ¿qué función cumple la medición de la tasa de mortalidad específica por dicha enfermedad?

A) Permite determinar el grado de cobertura del programa
B) Contribuye a evaluar la calidad del proceso de atención en el programa
C) Permite obtener una variable indirecta que refleja la efec2vidad del programa
D) Permite evaluar la eficiencia del proceso de aplicación del programa
E) Refleja el impacto del programa

Respuesta: E **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

La mortalidad específica por una patología grave es la variable más importante a ser evaluada, ya que mide la uGlidad e impacto del programa, así como su efecGvidad. No es una variable indirecta, sino directa. La eficiencia además requiere del análisis económico. La cobertura y la calidad de atención se miden con otras variables.

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 120 7.01.3.045 · Dirección: funciones de la

Se produce un accidente de tránsito de alta energía fuera de horario laboral, en el que un grupo de pacientes resulta lesionado de gravedad, siendo trasladados al servicio de urgencia, donde son recibidos por el médico de turno y hospitalizados para su tratamiento médico y quirúrgico. La prensa exige información sobre el estado de los pacientes de manera inmediata. ¿Quién debe realizar esta comunicación?

A) El médico de turno
B) El director del hospital
C) El encargado de relaciones públicas del hospital
D) La enfermera jefe del servicio de urgencia
E) El personal administra2vo del hospital

Respuesta: B **Fundamentación Oficial MINSAL / GES:**

Es una pregunta muy discuGble, ya que no hay ninguna obligación de informar a la prensa acerca de estos hechos y, por el contrario, la ley 20.585 (conocida como Ley de Derechos y Deberes del Paciente) establece la información de salud como confidencial. Sin embargo, de las opciones, la única aceptable es la Dirección del Hospital, por ser quien Gene la vocería institucional y, en la práctica, es quien da esta información, pero de manera muy superficial (ej. número de pacientes y gravedad, pero sin indicar nombres específicos).